



Manual de Bolso da Psicofarmacologia

Guia de consulta rápida para terapeutas

Dra. Tatiana Gontijo

Sumário

	Introdução	3
	Como usar o manual	4
	As Grandes Classes	5
	MEDICAÇÕES	
001	CLORIDRATO DE BUPROPIONA;CLORIDRATO DE NALTREXONA (Contrave)	8
002	CLORIDRATO DE NALTREXONA DI-HIDRATADO;CLORIDRATO DE BUPROPIONA (Reduxalt)	9
003	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA (Vertizan)	10
004	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA;MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA (Vertizine D)	11
005	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL (Cloridrato de Propranolol)	12
006	PROMETAZINA (Cremefenergan)	13
007	FUMARATO DE CLEMASTINA;ACETATO DE DEXAMETASONA (Emistin)	14
008	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA (Fosfato Sódico de Prednisolona)	15
009	PREDNISOLONA (Prednisolona)	16
010	PREDNISONA (Meticorten)	17
011	RAMELTEONA (Ramelteona)	18
012	EFAVIRENZ (Evir)	19
013	NUSINERSENA (Spinraza)	20
014	ONASEMNOGENO ABEPARVOVEQUE (Zolgensma)	21
015	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA (Cloridrato de Dexmedetomidina)	22
016	CLORIDRATO DE ESCETAMINA (Cloridrato de Escetamina)	23
017	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (Cloridrato de Midazolam)	24
018	MIDAZOLAM (Prontomid)	25
019	BUPRENORFINA (Buprenorfina)	26
020	CLORIDRATO DE METADONA (Mytedom)	27
021	CLORIDRATO DE OXICODONA;CLORIDRATO DE NALOXONA (Targin)	28
022	FENTANILA (Durogesic)	29

023	SULFATO DE MORFINA (Dimorf)	N2A	30
024	SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO (Dimorf Bolsa)	N2A	31
025	MESILATO DE DI-HIDROERGOTAMINA;DIPIRONA MONOIDRATADA;CAFEÍNA (Migraliv)	N2C9	32
026	GABAPENTINA (Gabapentina)	N2D	33
027	PREGABALINA (Jolik)	N2D	34
028	VIGABATRINA (Sabril)	N2D	35
029	CARBAMAZEPINA (Carbamazepina)	N3A	36
030	CLONAZEPAM (Clonazepam)	N3A	37
031	DIVALPROATO DE SÓDIO (Gaba Er)	N3A	38
032	ETOSSUXIMIDA (Etoxin)	N3A	39
033	FENITOÍNA (Fenital Oral)	N3A	40
034	FENITOÍNA SÓDICA (Fenital)	N3A	41
035	FENOBARBITAL (Fenobarbital)	N3A	42
036	LACOSAMIDA (Lakos)	N3A	43
037	LAMOTRIGINA (Lamotrigina)	N3A	44
038	LEVETIRACETAM (Levetiracetam)	N3A	45
039	OXCARBAZEPINA (Trileptal)	N3A	46
040	PERAMPANEL (Fycompa)	N3A	47
041	PRIMIDONA (Primid)	N3A	48
042	RUFINAMIDA (Inovelon)	N3A	49
043	SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAIDRATADO (Isofarma - Solução de Sulfato de Magnésio)	N3A	50
044	TOPIRAMATO (Égide)	N3A	51
045	VALPROATO DE SÓDIO (Valproato de Sódio)	N3A	52
046	CARBIDOPA (PORT. 344/98 LISTA C 1);ENTACAPONA;LEVODOPA (Stalevo)	N4A	53
047	CARBIDOPA (PORT. 344/98 LISTA C 1);LEVODOPA (Parkidopa)	N4A	54
048	CARBIDOPA MONOIDRATADA;LEVODOPA (Carbidopa Monoidratada + Levodopa)	N4A	55
049	CARBIDOPA;LEVODOPA (Carbidopa + Levodopa)	N4A	56
050	CLORIDRATO DE BENSERAZIDA;LEVODOPA (Prolopa)	N4A	57
051	CLORIDRATO DE BIPERIDENO (Cinetol)	N4A	58
052	CLORIDRATO DE SELEGILINA (Jumexil)	N4A	59
053	CLORIDRATO DE TRIEXIFENIDIL (Artane)	N4A	60
054	DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL (Dicloridrato de Pramipexol)	N4A	61
055	DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOIDRATADO (Quera)	N4A	62

056	MESILATO DE SAFINAMIDA (Xadago)	N4A	63
057	ROTIGOTINA (Neupro)	N4A	64
058	AMISSULPRIDA (Socian)	N5A1	65
059	ARIPIPAZOL (Aripiprazol)	N5A1	66
060	BREXPIPAZOL (Rexulti)	N5A1	67
061	CLORIDRATO DE LURASIDONA (Cloridrato de Lurasidona)	N5A1	68
062	CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA (Geodon)	N5A1	69
063	CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA MONOIDRATADO (Cloridrato de Ziprasidona)	N5A1	70
064	CLOZAPINA (Clozapina)	N5A1	71
065	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA (Hemifumarato de Quetiapina)	N5A1	72
066	OLANZAPINA (Olanzapina)	N5A1	73
067	PALIPERIDONA (Invega)	N5A1	74
068	PALMITATO DE PALIPERIDONA (Palmitato de Paliperidona)	N5A1	75
069	RISPERIDONA (Riss)	N5A1	76
070	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA (Cloridrato de Clorpromazina)	N5A9	77
071	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA (Levozine)	N5A9	78
072	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA (Unitidazin)	N5A9	79
073	DECANOATO DE HALOPERIDOL (Halo Decanoato)	N5A9	80
074	DICLORIDRATO DE FLUFENAZINA (Flufenan)	N5A9	81
075	DICLORIDRATO DE TRIFLUOPERAZINA (Stelazine)	N5A9	82
076	DICLORIDRATO DE ZUCLOPENTIXOL (Clopixol)	N5A9	83
077	ENANTATO DE FLUFENAZINA (Flufenan Depot)	N5A9	84
078	HALOPERIDOL (Haloperidol)	N5A9	85
079	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA (Maleato de Levomepromazina)	N5A9	86
080	PERICIAZINA (Neuleptil)	N5A9	87
081	SULPIRIDA (Equilid)	N5A9	88
082	CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA (Lenix)	N5B1	89
083	CLORIDRATO DE FLURAZEPAM (Dalmadorm)	N5B1	90
084	ESTAZOLAM (Noctal)	N5B1	91
085	ESZOPICLONA (Prysmá)	N5B1	92
086	FLUNITRAZEPAM (Rohypnol)	N5B1	93

087	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM (Hemitartarato de Zolpidem)	N5B1	94
088	LEMBOREXANTE (Dayvigo)	N5B1	95
089	MALEATO DE MIDAZOLAM (Dormonid)	N5B1	96
090	NITRAZEPAM (Nitrapan)	N5B1	97
091	ZOPICLONA (Imovane)	N5B1	98
092	CRATAEGUS RHIPIDOPHYLLA GAND.;PASSIFLORA INCARNATA;SALIX ALBA L. (Pasalix)	N5B5	99
093	EXTRATO SECO DE VALERIANA OFFICINALIS L. (Valerance)	N5B5	100
094	HUMULUS LUPULUS L.;VALERIANA OFFICINALIS L. (Remilev)	N5B5	101
095	PIPER METHYSTICUM (Kava Kava Herbarium)	N5B5	102
096	VALERIANA OFFICINALIS L. (Valerinati)	N5B5	103
097	ALPRAZOLAM (Alprazolam)	N5C	104
098	BROMAZEPAM (Bromazepam)	N5C	105
099	CLOBAZAM (Urbanil)	N5C	106
100	CLORIDRATO DE BUSPIRONA (Ansitec)	N5C	107
101	DIAZEPAM (Diazepam)	N5C	108
102	EXTRATO SECO DE PASSIFLORA (Fiquezen)	N5C	109
103	LORAZEPAM (Lorazepam)	N5C	110
104	EXTRATO SECO DE HYPERICUM PERFORATUM L (Hipericin)	N6A2	111
105	HYPERICUM PERFORATUM L. (Hyperinat)	N6A2	112
106	CARBONATO DE LÍCIO (Carbolitium)	N6A3	113
107	BROMIDRATO DE CITALOPRAM (Procimax)	N6A4	114
108	CITALOPRAM (Citalopram)	N6A4	115
109	CLORIDRATO DE FLUOXETINA (Verotina)	N6A4	116
110	CLORIDRATO DE PAROXETINA (Cebrilin)	N6A4	117
111	CLORIDRATO DE PAROXETINA HEMI-HIDRATADO (Pondera Xr)	N6A4	118
112	CLORIDRATO DE SERTRALINA (Cloridrato de Sertralina)	N6A4	119
113	HIDROBROMETO DE CITALOPRAM (PORT. 344/98 LISTA C 1) (Citalopram)	N6A4	120
114	MALEATO DE FLUVOXAMINA (Maleato de Fluvoxamina)	N6A4	121
115	OXALATO DE ESCITALOPRAM (Reconter)	N6A4	122
116	CLORIDRATO DE DULOXETINA (Velija)	N6A5	123
117	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (Venlaxin Xr)	N6A5	124

118	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO (Succinato de Desvenlafaxina Monoidratado)	N6A5	125
119	AGOMELATINA (Agomelatina)	N6A9	126
120	BROMIDRATO DE VORTIOXETINA (Voextor)	N6A9	127
121	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA (Cloridrato de Amitriptilina)	N6A9	128
122	CLORIDRATO DE BUPROPIONA (Zetron)	N6A9	129
123	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA (Cloridrato de Clomipramina)	N6A9	130
124	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA (Imipra)	N6A9	131
125	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA (Cloridrato de Nortriptilina)	N6A9	132
126	CLORIDRATO DE TRAZODONA (Sonic)	N6A9	133
127	CLORIDRATO DE VILAZODONA (Aymee)	N6A9	134
128	MIRTAZAPINA (Remeron)	N6A9	135
129	TIANEPTINA SÓDICA (Stablon)	N6A9	136
130	TRANILCIPROMINA (Parnate)	N6A9	137
131	ARMODAFINILA (Nuvigil)	N6B	138
132	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (Cloridrato de Metilfenidato)	N6B	139
133	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (Lysdexa)	N6B	140
134	MODAFINILA (Stavigile)	N6B	141
135	BROMAZEPAM;SULPIRIDA (Sulpan)	N6C	142
136	CLORDIAZEPÓXIDO;CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA (Limbitrol)	N6C	143
137	BACOPA MONNIERI (L.) WETTST. (Cognitus)	N6D	144
138	PIRACETAM (Nootropil)	N6D	145
139	ACETATO DE GLATIRÂMER (Copaxone)	N7A	146
140	ALENTUZUMABE (Lemtrada)	N7A	147
141	BETAINTERFERONA 1B (Betaferon)	N7A	148
142	BETAINTERFERONA 1A (Rebif)	N7A	149
143	CLADRIBINA (Mavenclad)	N7A	150
144	CLORIDRATO DE FINGOLIMODE (Gilenya)	N7A	151
145	FUMARATO DE DIMETILA (Fumarato de Dimetila)	N7A	152
146	NATALIZUMABE (Tysabri)	N7A	153
147	OCRELIZUMABE (Ocrevus)	N7A	154
148	OFATUMUMABE (Kesimpta)	N7A	155
149	TERIFLUNOMIDA (Teriflunomida)	N7A	156
150	TETRAIDROCANABINOL;CANABIDIOL (Mevatyl)	N7A	157

151	ÁCIDO FUMÁRICO SIPONIMODE (Kiendra)	N7A	158
152	NICOTINA (Nicorette)	N7B	159
153	TARTARATO DE VARENICLINA (Champix)	N7B	160
154	BROMIDRATO DE GALANTAMINA (Bromidrato de Galantamina)	N7D1	161
155	CLORIDRATO DE DONEPEZILA (Don)	N7D1	162
156	HEMITARTARATO DE RIVASTIGMINA (Hemitartarato de Rivastigmina)	N7D1	163
157	HIDROGENOTARTARATO DE RIVASTIGMINA (Vivencia)	N7D1	164
158	RIVASTIGMINA (Rivastigmina)	N7D1	165
159	CLORIDRATO DE MEMANTINA (Zider)	N7D9	166
160	CLORIDRATO DE MEMANTINA;CLORIDRATO DE DONEPEZILA (Cloridrato de Donepezila + Cloridrato de Memantina)	N7D9	167
161	CLORIDRATO DE MEMANTINA;CLORIDRATO DE DONEPEZILA MONOIDRATADO (Lábrea Duo)	N7D9	168
162	DONANEMABE (Kisunla)	N7D9	169
163	LECANEMABE (Leqembi)	N7D9	170
164	CLORIDRATO DE NALTREXONA (Revia)	N7E	171
165	CLORIDRATO DE NALOXONA (Narcan)	N7F	172
166	CLORIDRATO DE ATOMOXETINA (Atentah)	N7X	173
167	DEUTETRABENAZINA (Austedo)	N7X	174
168	RILUZOL (Riluzol)	N7X	175
169	SATRALIZUMABE (Enspryng)	N7X	176
170	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA (Hixizine)	R6A	177
171	CLORIDRATO DE PROMETAZINA (Cloridrato de Prometazina)	R6A	178
172	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA (Dicloridrato de Hidroxizina)	R6A	179
173	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA;HIDR OXIZINA;CLORIDRATO DE HIDROXIZINA (Cloridrato de Hidroxizina)	R6A	180
174	HIDROXIZINA (Pergo)	R6A	181

Introdução

O paciente menciona um nome que você não reconhece. Ou traz uma bula dobrada e pergunta: "Você sabe o que isso faz?" Você sabe que a pergunta importa. E sabe que responder com clareza faz parte do acompanhamento.

Somos nós que acompanhamos o paciente toda semana, que notamos quando algo mudou, que ouvimos o que ele não contou ao psiquiatra. Essa posição tem valor clínico, e ela exige um tipo específico de conhecimento: o da leitura do que aparece na sessão.

Este manual foi criado para isso. Cada ficha apresenta uma medicação do ponto de vista do que aparece na sessão: o que o paciente relata, o que é possível observar, onde a leitura clínica pode se confundir e quais perguntas ajudam a investigar sem invadir. O objetivo não é decorar classes farmacológicas. É reconhecer o que a medicação faz na presença do sujeito que você acompanha.

Como usar este manual

Este material foi desenhado para ser uma consulta rápida e prática. Cada ficha está dividida em campos que respondem às dúvidas mais comuns do terapeuta:

- **O que o paciente relata:** A linguagem subjetiva do efeito.
- **O que observar:** Mudanças objetivas de comportamento e afeto.
- **Efeitos que confundem:** Onde a clínica pode 'enganar' o terapeuta.
- **Perguntas úteis:** Como investigar o efeito sem ser invasiva.
- **Alertas de Urgência:** Sinais que exigem contato imediato com o médico.

Tenha-o sempre à mão (ou no tablet/celular) durante o atendimento ou na preparação do caso.

As Grandes Classes

Antes de entrar nas fichas individuais, é útil entender como as seis grandes famílias de psicofármacos funcionam na prática e como seus efeitos aparecem no setting terapêutico.

1. Antidepressivos (ISRS, Duais, Tricíclicos)

O que fazem: Alteram a disponibilidade de neurotransmissores (como serotonina e noradrenalina) para melhorar humor, energia e ansiedade crônica. Não são pílulas da felicidade; eles 'limpam a lente' para o paciente conseguir trabalhar em terapia.

Na clínica: Demoram de 2 a 4 semanas para fazer efeito. Nos primeiros dias, o paciente pode sentir *piora* da ansiedade. Em longo prazo ou doses altas, preste atenção no *embotamento emocional* ('fiquei anestesiado, não consigo chorar').

2. Benzodiazepínicos e Ansiolíticos

O que fazem: 'Freiam' o sistema nervoso central. São apagadores de incêndio para picos de ansiedade aguda, ataques de pânico e insônia pontual.

Na clínica: O efeito é imediato (minutos a horas). O grande risco é a dependência e a tolerância (precisar de mais para o mesmo efeito). Na sessão, o paciente sob efeito pode parecer mais lento, levemente sedado ou com lapsos de memória recente.

3. Estabilizadores de Humor

O que fazem: Seguram os 'polos'. Evitam as subidas (manias/hipomanias) e descidas (depressões) abruptas, formando a base do tratamento da bipolaridade.

Na clínica: Eles ajudam o paciente a ter uma linha de base emocional para poder elaborar questões na terapia. Não tiram a tristeza normal da vida, mas evitam que a tristeza vire um buraco negro. Exigem adesão rigorosa.

4. Antipsicóticos (Neurolépticos)

O que fazem: Desenvolvidos para delírios e alucinações (psicoses), hoje são muito usados em doses baixinhas para 'desligar a mente' à noite, tratar ansiedade severa ou irritabilidade grave.

Na clínica: Costumam 'esfriar' e sedar bastante no início. Podem causar rigidez muscular, tremores leves ou lentificação motora (efeitos extrapiramidais) que você consegue notar visualmente na sessão.

5. Estimulantes (Medicações para TDAH)

O que fazem: Aumentam dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal. O objetivo não é 'acelerar', mas dar *foco, atenção e controle de impulsos* para mentes dispersas.

Na clínica: O paciente medicado costuma ficar mais linear e organizado na fala. Como o efeito passa em algumas horas, observe o horário da sessão: um paciente à noite pode estar em 'rebote' (exausto ou muito irritado quando o remédio sai do corpo).

6. Medicações para o Sono (Hipnóticos/Sedativos)

O que fazem: Induzem ou mantêm o sono, 'desligando' a vigília do cérebro.

Na clínica: Extremamente úteis para tirar o paciente do esgotamento agudo, mas não curam a causa emocional da insônia. Se o paciente toma muito tarde, pode chegar 'de ressaca' (sonolento, confuso) na sessão da manhã seguinte. Alguns causam comportamentos noturnos sem memória no dia seguinte.

001 CLORIDRATO DE BUPROPIONA; CLORIDRATO DE NALTREXONA

Substância: Cloridrato de Bupropiona; Cloridrato de Naltrexona.

Nomes Comerciais: Contrave

Uso comum

- Combinação usada principalmente no manejo da obesidade, em geral quando o paciente já vem atravessando mudanças de rotina, alimentação e relação com o corpo. No consultório, tende a aparecer menos como “efeito do remédio” isolado e mais como parte de um processo com flutuações de apetite, impulso, energia, humor e adesão. Nas primeiras 2 a 6 semanas vale observar com mais atenção ativação, piora de ansiedade, insônia, náusea e ambivalência quanto à continuidade; ao longo de 1 a 3 meses, o foco costuma migrar para sustentação da rotina, impacto subjetivo da perda ou não perda de peso e risco de abandono silencioso. O ponto central na sessão é diferenciar mudança corporal e comportamental em curso de oscilação emocional, expectativa frustrada e uso irregular.

O paciente pode relatar

- **"Apetite e impulso:** Alguns pacientes descrevem menor urgência para comer, menos episódios de perda de controle ou mudança no valor subjetivo da comida; outros relatam oscilação importante, com dias de maior contenção e outros de busca alimentar intensa. Na sessão, isso pode aparecer como maior capacidade de pausa antes de comer, mas também como irritabilidade quando a comida deixa de cumprir função reguladora habitual. Convém não ler automaticamente como resposta estável ao tratamento: estresse, restrição excessiva, vergonha corporal e uso irregular podem produzir um padrão semelhante ou mascarar o que está acontecendo.

Ativação e ansiedade: No início, pode surgir aceleração subjetiva, inquietação, sensação de estar "ligado", impaciência ou aumento de ansiedade, às vezes confundidos com melhora de energia ou retomada de iniciativa. O terapeuta pode notar fala mais rápida, menor tolerância à frustração e dificuldade de permanecer em temas emocionalmente densos. A discriminação clínica importa porque esse quadro também pode refletir ansiedade basal, consumo de cafeína e outros estimulantes, privação de sono ou tentativa defensiva de retomar controle sobre o corpo.

Sono: Insônia inicial, sono mais leve ou dificuldade para desacelerar no fim do dia podem interferir no trabalho terapêutico, deixando o paciente mais reativo, concreto ou com menor acesso reflexivo. Em alguns casos, o cansaço subsequente se parece com piora depressiva ou desmotivação. Vale observar a sequência temporal entre início do uso, mudança no padrão de sono e oscilação do humor, sem perder de vista que dieta, exercício, dor, ansiedade e rotina irregular também podem explicar parte do quadro.

Humor e reatividade: Mudanças de humor podem aparecer tanto pela medicação quanto pelo contexto de tratamento do peso: esperança inicial, frustração com resultados lentos, vergonha, autocritica e sensibilidade a comentários sobre aparência. Em sessão, isso pode se traduzir em oscilação entre entusiasmo e desânimo, maior irritabilidade ou sensação de fracasso apesar de mudanças objetivas. A leitura fica mais precisa quando se compara com a linha de base e com eventos recentes, em vez de atribuir a variação a um único fator.

Imagem corporal: Mesmo quando há mudança de peso ou de apetite, a experiência subjetiva do corpo nem sempre melhora no mesmo ritmo. O paciente pode chegar mais vigilante com medidas, roupas, espelho e avaliação alheia, ou mais evitativo quando o resultado não corresponde à expectativa. Isso pode ser confundido com "falta de resposta" ao tratamento, quando na verdade o núcleo em sessão é autoestima, perfeccionismo, história de estigma corporal ou deslocamento do sofrimento para números e metas.

Adesão e continuidade: Náusea, desconforto subjetivo, custo emocional do tratamento e expectativa de resultado rápido podem favorecer uso irregular ou interrupção sem aviso, especialmente quando o paciente sente vergonha de admitir que não sustentou a rotina. Na sessão, isso às vezes aparece de forma indireta: relato vago sobre horários, respostas pouco consistentes sobre apetite e energia, ou mudança brusca no padrão entre uma semana e outra. Diferenciar baixa adesão de ineficácia percebida evita interpretações precipitadas sobre resistência, sabotagem ou "falta de vontade".

O que observar em sessão

- **Apetite e impulso:** Alguns pacientes descrevem menor urgência para comer, menos episódios de perda de controle ou mudança no valor subjetivo da comida; outros relatam oscilação importante, com dias de maior contenção e outros de busca alimentar intensa. Na sessão, isso pode aparecer como maior capacidade de pausa antes de comer, mas também como irritabilidade quando a comida deixa de cumprir função reguladora habitual. Convém não ler automaticamente como resposta estável ao tratamento: estresse, restrição excessiva, vergonha corporal e uso irregular podem produzir um padrão semelhante ou mascarar o que está acontecendo.

Ativação e ansiedade: No início, pode surgir aceleração subjetiva, inquietação, sensação de estar “ligado”, impaciência ou aumento de ansiedade, às vezes confundidos com melhora de energia ou retomada de iniciativa. O terapeuta pode notar fala mais rápida, menor tolerância à frustração e dificuldade de permanecer em temas emocionalmente densos. A discriminação clínica importa porque esse quadro também pode refletir ansiedade basal, consumo de cafeína e outros estimulantes, privação de sono ou tentativa defensiva de retomar controle sobre o corpo.

Sono: Insônia inicial, sono mais leve ou dificuldade para desacelerar no fim do dia podem interferir no trabalho terapêutico, deixando o paciente mais reativo, concreto ou com menor acesso reflexivo. Em alguns casos, o cansaço subsequente se parece com piora depressiva ou desmotivação. Vale observar a sequência temporal entre início do uso, mudança no padrão de sono e oscilação do humor, sem perder de vista que dieta, exercício, dor, ansiedade e rotina irregular também podem explicar parte do quadro.

Humor e reatividade: Mudanças de humor podem aparecer tanto pela medicação quanto pelo contexto de tratamento do peso: esperança inicial, frustração com resultados lentos, vergonha, autocritica e sensibilidade a comentários sobre aparência. Em sessão, isso pode se traduzir em oscilação entre entusiasmo e desânimo, maior irritabilidade ou sensação de fracasso apesar de mudanças objetivas. A leitura fica mais precisa quando se compara com a linha de base e com eventos recentes, em vez de atribuir a variação a um único fator.

Imagem corporal: Mesmo quando há mudança de peso ou de apetite, a experiência subjetiva do corpo nem sempre melhora no mesmo ritmo. O paciente pode chegar mais vigilante com medidas, roupas, espelho e avaliação alheia, ou mais evitativo quando o resultado não corresponde à expectativa. Isso pode ser confundido com “falta de resposta” ao tratamento, quando na verdade o núcleo em sessão é autoestima, perfeccionismo, história de estigma corporal ou deslocamento do sofrimento para números e metas.

Adesão e continuidade: Náusea, desconforto subjetivo, custo emocional do tratamento e expectativa de resultado rápido podem favorecer uso irregular ou interrupção sem aviso, especialmente quando o paciente sente vergonha de admitir que não sustentou a rotina. Na sessão, isso às vezes aparece de forma indireta: relato vago sobre horários, respostas pouco consistentes sobre apetite e energia, ou mudança brusca no padrão entre uma semana e outra. Diferenciar baixa adesão de ineficácia percebida evita interpretações precipitadas sobre resistência, sabotagem ou “falta de vontade”.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Combinação usada principalmente no manejo da obesidade, em geral quando o paciente já vem atravessando mudanças de rotina, alimentação e relação com o corpo. No consultório, tende a aparecer menos como “efeito do remédio” isolado e mais como parte de um processo com flutuações de apetite, impulso, energia, humor e adesão. Nas primeiras 2 a 6 semanas vale observar com mais atenção ativação, piora de ansiedade, insônia, náusea e ambivalência quanto à continuidade; ao longo de 1 a 3 meses, o foco costuma migrar para sustentação da rotina, impacto subjetivo da perda ou não perda de peso e risco de abandono silencioso. O ponto central na sessão é diferenciar mudança corporal e comportamental em curso de oscilação emocional, expectativa frustrada e uso irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe menos vontade de comer, isso vem como uma redução mais estável do impulso ou como um esforço tenso de se segurar diante da comida? , Essa sensação de estar mais acelerado se parece mais com ansiedade desconfortável no corpo ou com energia organizada para fazer as coisas? , Nos dias em que você dorme pior, o desânimo do dia seguinte parece cansaço e irritação ou volta daquele humor depressivo que você já conhecia antes? , Quando você se frustra com o peso ou com a rotina, o sofrimento fica mais ligado ao resultado na balança, à imagem no espelho ou a uma sensação mais ampla de fracasso pessoal? , Nas semanas em que seu apetite, humor ou energia mudaram de forma brusca, o uso ficou regular ou houve dias pulados, interrupções ou vontade de parar sem contar para ninguém? , Quando você diz que está melhor, isso aparece também em mais flexibilidade e bem-estar no dia a dia ou principalmente em mais controle sobre comer e sobre o corpo?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta ansiedade
- insônia ou inquietação persistentes nas primeiras semanas a ponto de comprometer funcionamento
- vínculo ou continuidade do uso
- pode valer alinhar com o médico assistente para contextualizar a tolerabilidade inicial
- Quando surgem piora importante do humor
- irritabilidade incomum ou ideias de morte após o início ou em mudança recente do padrão de uso
- pode valer comunicação com o médico para avaliação clínica mais rápida
- Quando o paciente relata uso irregular
- interrupções repetidas ou intenção de abandonar silenciosamente por desconforto ou frustração
- pode valer alinhar com o médico para evitar que a leitura clínica fique baseada em um uso não sustentado
- Quando há ausência de mudança percebida após cerca de 1 a 3 meses
- apesar de engajamento consistente no tratamento e na rotina

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer contato com o médico para situar a evolução observada
- Quando a sessão sugere aceleração importante
- redução marcante da necessidade de sono
- impulsividade ou expansividade fora da linha de base
- pode valer comunicação com o médico para esclarecer se há mudança de humor clinicamente relevante

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem ideias de morte
- autoagressão ou piora abrupta do desespero
- especialmente nas primeiras semanas ou após mudança recente no uso.: Fazer avaliação de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- e considerar emergência conforme gravidade
- Surge aceleração muito acima da linha de base
- com fala pressionada
- pouca necessidade de sono
- impulsividade e sensação de grandiosidade ou descontrole.: Tratar como mudança aguda relevante
- reduzir a espera entre contatos e acionar o médico no mesmo dia; considerar apoio de emergência se houver risco comportamental
- O paciente chega confuso
- muito agitado
- com tremores marcados
- sudorese intensa ou mal-estar importante que dificulta sustentar a sessão.: Interromper a exploração psicoterápica
- buscar avaliação médica imediata e acionar emergência se o estado geral estiver comprometido

Frase clínica

O foco clínico é distinguir redução do impulso alimentar de ativação ansiosa, frustração com o peso e adesão irregular ao tratamento.

002 CLORIDRATO DE NALTREXONA DI-HIDRATADO; CLORIDRATO DE BUPROPIONA

Substância: Cloridrato de Naltrexona Di-Hidratado; Cloridrato de Bupropiona.

Nomes Comerciais: Reduxalt, Sliv, Bupnal

Uso comum

- Combinação usada sobretudo no manejo da obesidade, geralmente em pacientes já atravessados por ciclos de dieta, frustração corporal e oscilação de motivação. No consultório, tende a aparecer menos como “medicação psiquiátrica” e mais como parte de um tratamento com forte carga subjetiva sobre controle, culpa e autoimagem. Nas primeiras 2 a 6 semanas, vale observar mais de perto ativação, piora do sono, irritabilidade, náusea e mudanças no apetite; depois, o foco costuma migrar para adesão, expectativa de resultado e impacto emocional da resposta corporal. Se houver interrupções irregulares, a leitura clínica pode se confundir com recaída de compulsão, desânimo ou abandono do cuidado.

O paciente pode relatar

- **"Apetite e controle:** O paciente pode descrever redução da fome, menor urgência para beliscar ou, em sentido oposto, sensação de que o impulso alimentar continua apesar da medicação. Em sessão, isso às vezes aparece como maior capacidade de pausa antes de comer, mas também pode surgir como vigilância excessiva, rigidez ou culpa quando a perda de controle persiste. Convém diferenciar mudança sustentada no padrão alimentar de um período breve de entusiasmo, de contenção baseada em esforço e de oscilações ligadas a estresse, rotina ou adesão irregular.

Ativação e ansiedade: Nas primeiras semanas, alguns pacientes chegam mais acelerados, irritáveis, impacientes ou com sensação de tensão interna, o que pode ser confundido com ansiedade basal, pressão por emagrecer ou aumento de demandas externas. A observação clínica ajuda quando se compara o ritmo da fala, a tolerância à frustração e a capacidade de permanecer na sessão com a linha de base anterior. Se a ativação surge de modo mais abrupto após início ou retomada e não acompanha um tema emocional claro, pode valer registrar como hipótese relacionada ao tratamento em curso.

Sono: Dificuldade para iniciar o sono, sono mais leve ou sensação de descanso insuficiente podem aparecer cedo e alterar o tom da sessão, com mais cansaço, impaciência ou menor elaboração. Isso pode se parecer com piora ansiosa, sobrecarga cotidiana ou desorganização de hábitos, especialmente quando o paciente também está mudando alimentação e rotina. A discriminação clínica costuma depender de mapear se a alteração do sono começou junto com o tratamento, se varia conforme regularidade de uso e se repercute no humor e no autocontrole alimentar no dia seguinte.

Humor e reatividade: A combinação pode entrar em cena em pacientes com histórico de desânimo, vergonha corporal e autocrítica, e a melhora inicial do senso de controle às vezes convive com irritabilidade ou labilidade. Em sessão, importa distinguir alívio por retomada de cuidado de uma mudança mais abrupta de energia e reatividade, assim como separar frustração por resultado corporal lento de um rebaixamento mais amplo do humor. Quando o paciente oscila entre esperança intensa e queda acentuada diante de pequenos desvios, o medicamento pode estar compondo o quadro, mas não explica sozinho a dinâmica.

Imagem corporal: Mesmo quando há mudança objetiva de peso ou apetite, o sofrimento com o corpo pode permanecer quase intacto, e isso costuma aparecer como desqualificação de qualquer progresso, comparação constante e vergonha persistente. Em outros casos, a medicação vira depositária de expectativa de reparação rápida, o que torna a sessão mais sensível a decepções e abandono. Vale observar se a experiência subjetiva do corpo mudou de fato ou se apenas se deslocou o foco da crítica, porque isso ajuda a não confundir resposta corporal parcial com melhora emocional mais ampla.

Adesão e abandono silencioso: Náusea, insônia, irritabilidade, custo, vergonha de admitir que não percebeu benefício ou retomada de episódios de comer compulsivo podem levar a uso irregular sem que isso apareça espontaneamente. Na sessão, o indício às vezes é uma narrativa pouco linear sobre horários, esquecimentos frequentes ou mudanças bruscas entre “está ajudando” e “não fez diferença nenhuma”. Diferenciar baixa adesão de ineficácia percebida e de

oscilação do próprio quadro evita atribuir ao tratamento, com excesso de certeza, aquilo que pode refletir uso intermitente ou interrupção por conta própria."

O que observar em sessão

- **Apetite e controle:** O paciente pode descrever redução da fome, menor urgência para beliscar ou, em sentido oposto, sensação de que o impulso alimentar continua apesar da medicação. Em sessão, isso às vezes aparece como maior capacidade de pausa antes de comer, mas também pode surgir como vigilância excessiva, rigidez ou culpa quando a perda de controle persiste. Convém diferenciar mudança sustentada no padrão alimentar de um período breve de entusiasmo, de contenção baseada em esforço e de oscilações ligadas a estresse, rotina ou adesão irregular.

Ativação e ansiedade: Nas primeiras semanas, alguns pacientes chegam mais acelerados, irritáveis, impacientes ou com sensação de tensão interna, o que pode ser confundido com ansiedade basal, pressão por emagrecer ou aumento de demandas externas. A observação clínica ajuda quando se compara o ritmo da fala, a tolerância à frustração e a capacidade de permanecer na sessão com a linha de base anterior. Se a ativação surge de modo mais abrupto após início ou retomada e não acompanha um tema emocional claro, pode valer registrar como hipótese relacionada ao tratamento em curso.

Sono: Dificuldade para iniciar o sono, sono mais leve ou sensação de descanso insuficiente podem aparecer cedo e alterar o tom da sessão, com mais cansaço, impaciência ou menor elaboração. Isso pode se parecer com piora ansiosa, sobrecarga cotidiana ou desorganização de hábitos, especialmente quando o paciente também está mudando alimentação e rotina. A discriminação clínica costuma depender de mapear se a alteração do sono começou junto com o tratamento, se varia conforme regularidade de uso e se repercute no humor e no autocontrole alimentar no dia seguinte.

Humor e reatividade: A combinação pode entrar em cena em pacientes com histórico de desânimo, vergonha corporal e autocrítica, e a melhora inicial do senso de controle às vezes convive com irritabilidade ou labilidade. Em sessão, importa distinguir alívio por retomada de cuidado de uma mudança mais abrupta de energia e reatividade, assim como separar frustração por resultado corporal lento de um rebaixamento mais amplo do humor. Quando o paciente oscila entre esperança intensa e queda acentuada diante de pequenos desvios, o medicamento pode estar compondo o quadro, mas não explica sozinho a dinâmica.

Imagem corporal: Mesmo quando há mudança objetiva de peso ou apetite, o sofrimento com o corpo pode permanecer quase intacto, e isso costuma aparecer como desqualificação de qualquer progresso, comparação constante e vergonha persistente. Em outros casos, a medicação vira depositária de expectativa de reparação rápida, o que torna a sessão mais sensível a decepções e abandono. Vale observar se a experiência subjetiva do corpo mudou de fato ou se apenas se deslocou o foco da crítica, porque isso ajuda a não confundir resposta corporal parcial com melhora emocional mais ampla.

Adesão e abandono silencioso: Náusea, insônia, irritabilidade, custo, vergonha de admitir que não percebeu benefício ou retomada de episódios de comer compulsivo podem levar a uso irregular sem que isso apareça espontaneamente. Na sessão, o indício às vezes é uma narrativa pouco linear sobre horários, esquecimentos frequentes ou mudanças bruscas entre “está ajudando” e “não fez diferença nenhuma”. Diferenciar baixa adesão de ineficácia percebida e de

oscilação do próprio quadro evita atribuir ao tratamento, com excesso de certeza, aquilo que pode refletir uso intermitente ou interrupção por conta própria.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Combinação usada sobretudo no manejo da obesidade, geralmente em pacientes já atravessados por ciclos de dieta, frustração corporal e oscilação de motivação. No consultório, tende a aparecer menos como “medicação psiquiátrica” e mais como parte de um tratamento com forte carga subjetiva sobre controle, culpa e autoimagem. Nas primeiras 2 a 6 semanas, vale observar mais de perto ativação, piora do sono, irritabilidade, náusea e mudanças no apetite; depois, o foco costuma migrar para adesão, expectativa de resultado e impacto emocional da resposta corporal. Se houver interrupções irregulares, a leitura clínica pode se confundir com recaída de compulsão, desânimo ou abandono do cuidado.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe mais tensão ou irritação, isso parece vir junto de pensamentos preocupados e temas da sua vida, ou aparece mais como um estado corporal de aceleração sem assunto claro? , A mudança na sua alimentação tem parecido mais uma redução espontânea da urgência para comer ou um esforço de se segurar na base da força de vontade? , Seu sono piorou ao mesmo tempo em que você começou ou retomou o tratamento, ou já vinha se alterando antes por estresse, rotina ou humor? , Quando você diz que está “melhor”, isso aparece também em mais interesse, presença afetiva e flexibilidade, ou principalmente em sentir menos fome e mais controle? , Nos dias em que a compulsão ou o beliscar voltam, isso costuma acontecer mesmo mantendo a rotina de uso, ou coincide com esquecimentos, interrupções ou fins de semana diferentes? , Essa irritabilidade recente parece proporcional ao que está acontecendo na sua vida, ou você sente que está reagindo de um jeito mais intenso do que o seu habitual?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente relata uso irregular
- interrupções repetidas ou abandono silencioso por desconforto
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer a leitura clínica da resposta e do sofrimento associado
- Quando surgem insônia persistente
- irritabilidade importante ou aceleração que alteram o funcionamento e o padrão da sessão nas primeiras semanas
- pode valer comunicar para reavaliar a tolerabilidade do tratamento em curso
- Quando o paciente descreve piora relevante do humor
- desesperança ou aumento de pensamentos de morte após início ou retomada
- especialmente se houver pouca capacidade de discriminar gatilhos externos
- pode valer contato com o médico pela mudança temporal do quadro
- Quando a redução do apetite vem acompanhada de rigidez crescente

Amarelo: alinhar em breve

- culpa intensa ao comer ou escalada de comportamentos compensatórios
- pode valer alinhar com o médico porque o tratamento pode estar se articulando a um padrão alimentar mais desorganizado
- Quando não há benefício percebido após algumas semanas de uso regular e isso aumenta desânimo
- autocrítica ou risco de abandono global do cuidado
- pode valer comunicação para situar a frustração no plano terapêutico mais amplo

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem pensamentos de morte mais frequentes
- planejamento suicida
- sensação de que seria melhor desaparecer ou perda importante de controle sobre impulsos.: Fazer avaliação de risco na hora
- acionar psiquiatra e rede de apoio hoje e encaminhar para emergência quando necessário
- Surge mudança abrupta com pouca necessidade de sono
- fala muito acelerada
- grandiosidade
- agitação incomum ou condutas claramente fora do padrão do paciente.: Tratar como mudança aguda do estado mental
- contatar o médico assistente no mesmo dia e mobilizar rede de apoio se houver risco
- O paciente relata uso de opioides enquanto está em tratamento e chega à sessão com mal-estar intenso
- agitação
- sudorese
- vômitos ou dor importante após essa combinação.: Considerar situação de urgência clínica
- orientar busca imediata de avaliação médica e acionar suporte emergencial se o estado geral estiver comprometido

Frase clínica

O foco clínico é separar mudança real no apetite e no autocontrole de ativação, insônia, adesão irregular e sofrimento persistente com o corpo.

003 DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA

Substância: Dicloridrato de Flunarizina.

Nomes Comerciais: Vertizan, Dicloridrato de Flunarizina, Vertix, Flunarin, Vertigium

Uso comum

- A flunarizina é um medicamento usado sobretudo em prevenção de enxaqueca e em quadros vestibulares, portanto costuma aparecer no consultório em pacientes que já chegam com histórico de dor, tontura, náusea, insegurança corporal e limitação funcional. Na prática da terapia, o mais útil é acompanhar o que muda nas primeiras 2 a 6 semanas após início ou retomada e o que se consolida ao longo de 1 a 3 meses: sonolência, lentificação, aumento do apetite, ganho de peso e rebaixamento do humor podem entrar no campo de confusão com depressão, exaustão crônica ou impacto da própria condição de base. O foco clínico é distinguir melhora da crise física de empobrecimento subjetivo, além de notar sinais motores ou afetivos novos que alterem o trabalho em sessão.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com bocejos, dificuldade de sustentar atenção, fala menos espontânea e sensação de corpo pesado. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva ou desinvestimento no processo, mas também pode coincidir com noites mal dormidas pela dor, fadiga acumulada ou outras medicações sedativas em uso. Vale comparar com a linha de base anterior ao início do medicamento e observar se a lentificação é mais corporal do que afetiva, se varia ao longo do dia e se o paciente segue com interesse psíquico apesar da baixa energia.

Humor rebaixado: Alguns pacientes passam a descrever menos vitalidade, menor iniciativa, redução do prazer e uma tonalidade mais cinza da experiência, às vezes de instalação gradual nas semanas seguintes ao início. Na sessão, isso pode se confundir com desmoralização por crises recorrentes, frustração com limitações funcionais ou evolução de um quadro depressivo já em curso. A discriminação clínica fica mais consistente quando se investiga a sequência temporal, a presença de culpa, desesperança e autodepreciação, e se houve melhora das queixas físicas ao mesmo tempo em que o humor empobreceu.

Apetite e peso: Aumento do apetite, comer mais por impulso ou ganho de peso podem surgir como tema relevante e afetar autoestima, imagem corporal e adesão silenciosa. No consultório, isso pode aparecer como vergonha, irritação com o próprio corpo ou sensação de perda de controle, mas também pode refletir redução de atividade física por tontura, comer emocional diante de dor crônica ou mudanças hormonais e de rotina. Mais do que quantificar, interessa notar se a mudança foi percebida como abrupta, se alterou o vínculo com o tratamento e se está sendo atribuída pelo paciente a si mesmo de modo excessivamente moralizado.

Cognição e atenção: Pode haver queixas de cabeça mais lenta, dificuldade de concentração e menor agilidade mental, especialmente em pacientes que já chegam sobrecarregados por dor frequente, privação de sono ou ansiedade antecipatória por novas crises. Em sessão, isso se traduz por maior latência para responder, perda do fio da narrativa e menor capacidade de elaboração, o que pode ser confundido com resistência, dissociação leve ou esgotamento emocional. A leitura fica mais precisa quando se compara o desempenho entre sessões, se observa a relação com sonolência e se diferencia uma mente cansada de um afastamento defensivo do conteúdo emocional.

Sinais motores: Embora não sejam os achados mais frequentes no consultório de terapia, rigidez, lentidão incomum, inquietação corporal estranha ao padrão do paciente ou tremor novo merecem atenção quando aparecem após o início do uso. Esses sinais podem ser atribuídos pelo próprio paciente a ansiedade, tensão muscular, envelhecimento ou cansaço, e às vezes passam despercebidos se o terapeuta olha apenas para o conteúdo verbal. Quando surgem junto de empobrecimento afetivo, redução de espontaneidade ou piora funcional, vale registrar concretamente o que foi observado e considerar comunicação clínica."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com bocejos, dificuldade de sustentar atenção, fala menos espontânea e sensação de corpo pesado. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva ou desinvestimento no processo, mas também pode coincidir com noites mal dormidas pela dor, fadiga acumulada ou outras medicações sedativas em uso. Vale comparar com a linha de base anterior ao início do medicamento e observar se a lentificação é mais corporal do que afetiva, se varia ao longo do dia e se o paciente segue com interesse psíquico apesar da baixa energia.

Humor rebaixado: Alguns pacientes passam a descrever menos vitalidade, menor iniciativa, redução do prazer e uma tonalidade mais cinza da experiência, às vezes de instalação gradual nas semanas seguintes ao início. Na sessão, isso pode se confundir com desmoralização por crises recorrentes, frustração com limitações funcionais ou evolução de um quadro depressivo já em curso. A discriminação clínica fica mais consistente quando se investiga a sequência temporal, a presença de culpa, desesperança e autodepreciação, e se houve melhora das queixas físicas ao mesmo tempo em que o humor empobreceu.

Apetite e peso: Aumento do apetite, comer mais por impulso ou ganho de peso podem surgir como tema relevante e afetar autoestima, imagem corporal e adesão silenciosa. No consultório, isso pode aparecer como vergonha, irritação com o próprio corpo ou sensação de perda de controle, mas também pode refletir redução de atividade física por tontura, comer emocional diante de dor crônica ou mudanças hormonais e de rotina. Mais do que quantificar, interessa notar se a mudança foi percebida como abrupta, se alterou o vínculo com o tratamento e se está sendo atribuída pelo paciente a si mesmo de modo excessivamente moralizado.

Cognição e atenção: Pode haver queixas de cabeça mais lenta, dificuldade de concentração e menor agilidade mental, especialmente em pacientes que já chegam sobrecarregados por dor frequente, privação de sono ou ansiedade antecipatória por novas crises. Em sessão, isso se traduz por maior latência para responder, perda do fio da narrativa e menor capacidade de elaboração, o que pode ser confundido com resistência, dissociação leve ou esgotamento emocional. A leitura fica mais precisa quando se compara o desempenho entre sessões, se observa a relação com sonolência e se diferencia uma mente cansada de um afastamento defensivo do conteúdo emocional.

Sinais motores: Embora não sejam os achados mais frequentes no consultório de terapia, rigidez, lentidão incomum, inquietação corporal estranha ao padrão do paciente ou tremor novo merecem atenção quando aparecem após o início do uso. Esses sinais podem ser atribuídos pelo próprio paciente a ansiedade, tensão muscular, envelhecimento ou cansaço, e às vezes passam despercebidos se o terapeuta olha apenas para o conteúdo verbal. Quando surgem junto de empobrecimento afetivo, redução de espontaneidade ou piora funcional, vale registrar concretamente o que foi observado e considerar comunicação clínica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A flunarizina é um medicamento usado sobretudo em prevenção de enxaqueca e em quadros vestibulares, portanto costuma aparecer no consultório em pacientes que já chegam com histórico de dor, tontura, náusea, insegurança corporal e limitação funcional. Na prática da terapia, o mais útil é acompanhar o que muda nas primeiras 2 a 6 semanas após início ou retomada e o que se consolida ao longo de 1 a 3 meses: sonolência, lentificação, aumento do apetite, ganho de peso e rebaixamento do humor podem entrar no campo de confusão com depressão, exaustão crônica ou impacto da própria condição de base. O foco clínico é distinguir melhora da crise física de empobrecimento subjetivo, além de notar sinais motores ou afetivos novos que alterem o trabalho em sessão.

Perguntas úteis

- "Essa lentidão que você percebe parece mais sono e corpo pesado, ou vem junto de tristeza, culpa e perda de interesse pelas coisas? , Quando seu humor piorou, isso aconteceu antes, junto ou depois de alguma mudança nas crises de tontura ou dor de cabeça? , Você sente que está menos interessado nas coisas porque está desanimado por dentro, ou porque seu corpo ficou mais cansado e sem ritmo? , Essa dificuldade de concentração aparece o tempo todo ou fica mais forte em certos horários, especialmente quando você está mais sonolento? , O aumento de apetite ou de peso mudou sua relação com o tratamento a ponto de você pular dias, reduzir por conta própria ou pensar em parar sem comentar com o médico? , Essa inquietação ou estranheza no corpo parece a sua ansiedade habitual, ou é uma sensação mais nova, física, difícil de controlar mesmo quando sua cabeça não está acelerada?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente mais sonolento
- lentificado ou cognitivamente embotado do que sua linha de base
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar efeito do tratamento
- piora clínica ou combinação com outras medicações
- Quando surge rebaixamento de humor nas semanas após início ou retomada
- sobretudo se acompanhado de perda de iniciativa e empobrecimento afetivo
- pode valer comunicar para avaliação da relação temporal e do impacto funcional
- Quando ganho de peso
- aumento importante do apetite ou incômodo corporal começam a favorecer abandono silencioso ou uso irregular
- pode valer informar o médico assistente porque a adesão pode estar se deteriorando sem ter sido explicitada na consulta
- Quando aparecem tremor
- rigidez
- lentidão motora nova ou inquietação corporal incomum
- pode valer contato com o médico para avaliação clínica desses sinais

Amarelo: alinhar em breve

- Quando não há melhora perceptível das crises físicas após 1 a 3 meses e o paciente segue sobrecarregado por limitações e efeitos subjetivos difíceis de tolerar
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisão do quadro e da adesão

Vermelho: tratar como urgência

- Ideias de morte
- desesperança intensa ou fala de que a vida perdeu o sentido em contexto de humor rebaixado recente
- especialmente se houve piora rápida.: Fazer avaliação de risco na hora e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Rebaixamento importante do nível de alerta
- confusão marcante ou dificuldade incomum de se manter acordado e orientado durante a sessão.: Interromper o enquadre habitual e providenciar avaliação médica no mesmo dia
- com apoio de acompanhante ou serviço de urgência se preciso

Frase clínica

Na terapia, o ponto central com flunarizina é separar melhora da queixa física de lentificação, ganho de peso e rebaixamento do humor que alteram a sessão.

004 DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA; MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA

Substância: Dicloridrato de Flunarizina; Mesilato de Diidroergocristina.

Nomes Comerciais: Vertizine D

Uso comum

- Associação usada em contextos de tontura, vertigem e queixas circulatórias, mais provável no consultório como parte de um tratamento clínico não psiquiátrico. Para o terapeuta, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como o paciente em acompanhamento por sintomas físicos persistentes chega à sessão: oscilação de energia, lentificação, desconforto corporal, insegurança para sair ou se locomover e impacto funcional. Se houver mudança recente no tratamento, vale observar as primeiras semanas em busca de alteração do padrão habitual de sono, disposição, humor e clareza cognitiva. Também ajuda acompanhar se a melhora ou piora acompanha a intensidade da tontura ou aparece de modo mais dissociado dela.

O paciente pode relatar

- **"Lentificação e vigília:** Em parte dos pacientes pode aparecer sonolência, redução do ritmo ou sensação de cabeça mais pesada, algo que na sessão se traduz em fala mais lenta, menor prontidão associativa ou dificuldade de sustentar atenção. Isso pode ser confundido com humor deprimido, exaustão por noites ruins ou efeito do próprio quadro vestibular, que por si só já desgasta e reduz iniciativa. A leitura clínica fica mais precisa quando se compara com a baseline do paciente e com o momento em que essas mudanças começaram em relação ao início do tratamento e à intensidade dos sintomas físicos.

Humor e retraimento: Quando a tontura se prolonga, o paciente pode chegar mais desanimado, irritado ou socialmente retraído, e nem sempre é simples distinguir sofrimento reativo à limitação funcional de uma mudança mais marcada do tônus afetivo. Em alguns casos, a sessão mostra menos acesso afetivo, menos interesse e mais passividade do que o habitual. Vale considerar eventos de vida, frustração acumulada com o tratamento e outras medicações em uso antes de atribuir a mudança a um único fator.

Cognição na sessão: Queixas de concentração, memória imediata ou sensação de estar menos nítido podem aparecer tanto pelo tratamento quanto pelo cansaço de lidar com vertigem, náusea, insegurança corporal e hipervigilância somática. Na sessão, isso pode surgir como perda do fio, necessidade de repetir perguntas ou dificuldade de elaborar experiências recentes. A discriminação depende de observar se a oscilação cognitiva acompanha momentos de mais tontura e mal-estar ou se se mantém mesmo quando o sintoma físico está mais controlado.

Ansiedade por instabilidade corporal: Muitos pacientes desenvolvem ansiedade antecipatória ligada ao medo de passar mal, cair, sair sozinho ou circular em ambientes movimentados. Esse padrão pode parecer um agravamento ansioso primário, mas às vezes está fortemente ancorado na experiência corporal de instabilidade e na evitação que se segue. Na sessão, ajuda notar se a ansiedade cresce em contextos específicos de movimento e exposição ou se se apresenta de forma mais difusa, independente das situações que evocam vertigem."

O que observar em sessão

- **Lentificação e vigília:** Em parte dos pacientes pode aparecer sonolência, redução do ritmo ou sensação de cabeça mais pesada, algo que na sessão se traduz em fala mais lenta, menor prontidão associativa ou dificuldade de sustentar atenção. Isso pode ser confundido com humor deprimido, exaustão por noites ruins ou efeito do próprio quadro vestibular, que por si só já desgasta e reduz iniciativa. A leitura clínica fica mais precisa quando se compara com a baseline do paciente e com o momento em que essas mudanças começaram em relação ao início do tratamento e à intensidade dos sintomas físicos.

Humor e retraimento: Quando a tontura se prolonga, o paciente pode chegar mais desanimado, irritado ou socialmente retraído, e nem sempre é simples distinguir sofrimento reativo à limitação funcional de uma mudança mais marcada do tônus afetivo. Em alguns casos, a sessão mostra menos acesso afetivo, menos interesse e mais passividade do que o habitual. Vale considerar eventos de vida, frustração acumulada com o tratamento e outras medicações em uso antes de atribuir a mudança a um único fator.

Cognição na sessão: Queixas de concentração, memória imediata ou sensação de estar menos nítido podem aparecer tanto pelo tratamento quanto pelo cansaço de lidar com vertigem, náusea, insegurança corporal e hipervigilância somática. Na sessão, isso pode surgir como perda do fio, necessidade de repetir perguntas ou dificuldade de elaborar experiências recentes. A discriminação depende de observar se a oscilação cognitiva acompanha momentos de mais tontura e mal-estar ou se se mantém mesmo quando o sintoma físico está mais controlado.

Ansiedade por instabilidade corporal: Muitos pacientes desenvolvem ansiedade antecipatória ligada ao medo de passar mal, cair, sair sozinho ou circular em ambientes movimentados. Esse padrão pode parecer um agravamento ansioso primário, mas às vezes está fortemente ancorado na experiência corporal de instabilidade e na evitação que se segue. Na sessão, ajuda notar se a ansiedade cresce em contextos específicos de movimento e exposição ou se se apresenta de forma mais difusa, independente das situações que evocam vertigem.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Associação usada em contextos de tontura, vertigem e queixas circulatórias, mais provável no consultório como parte de um tratamento clínico não psiquiátrico. Para o terapeuta, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como o paciente em acompanhamento por sintomas físicos persistentes chega à sessão: oscilação de energia, lentificação, desconforto corporal, insegurança para sair ou se locomover e impacto funcional. Se houver mudança recente no tratamento, vale observar as primeiras semanas em busca de alteração do padrão habitual de sono, disposição, humor e clareza cognitiva. Também ajuda acompanhar se a melhora ou piora acompanha a intensidade da tontura ou aparece de modo mais dissociado dela.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso aparece como um peso no corpo e na atenção ou vem junto de tristeza, desesperança e perda de interesse? , Nos dias em que sua concentração piora, a tontura ou o mal-estar físico também estão mais presentes, ou a sensação de cabeça confusa aparece mesmo quando o corpo está relativamente melhor? , Esse receio de sair, andar ou se expor a certos lugares parece vir principalmente do medo de passar mal fisicamente ou se parece mais com a sua ansiedade habitual, mesmo sem sintomas corporais naquele momento? , Você percebeu essa mudança de disposição e ritmo logo depois de começar o tratamento, ou ela foi crescendo junto com o desgaste de lidar com os sintomas e as limitações na rotina? , Quando você evita atividades, isso acontece porque está sem energia e iniciativa de modo geral ou porque teme desencadear tontura, mal-estar ou desequilíbrio?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- Identificado ou cognitivamente menos nítido do que sua baseline
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se há relação temporal com o tratamento ou com outras condições clínicas em curso
- Quando surge rebaixamento importante de humor
- retraimento incomum ou perda de interesse que não se explica apenas pelo impacto funcional da tontura
- pode valer comunicar o médico para avaliação conjunta do quadro
- Quando a adesão fica irregular porque o paciente associa o uso a mal-estar
- sonolência ou piora subjetiva e começa a omitir doses por conta própria
- pode valer alinhar com o médico para reduzir abandono silencioso do tratamento
- Quando a ansiedade e a evitação aumentam a ponto de restringir deslocamentos
- trabalho ou autocuidado
- pode valer contato com o médico para integrar a leitura entre sintoma físico
- sofrimento psíquico e funcionalidade

Vermelho: tratar como urgência

- Ideias de morte
- autoagressão ou desesperança intensa emergem junto de piora importante do estado mental
- independentemente da causa presumida.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e contato médico; recorrer à emergência quando houver risco iminente
- Confusão marcante
- rebaixamento importante do nível de alerta
- fala muito desconexa ou incapacidade súbita de se orientar na sessão.: Interromper o trabalho interpretativo

Vermelho: tratar como urgência

- avaliar necessidade de suporte imediato e acionar atendimento médico no mesmo dia
- com emergência se houver comprometimento relevante da segurança

Frase clínica

O foco é distinguir lentificação, desânimo e ansiedade reativa ao sintoma físico de uma mudança mais ampla do estado mental e da funcionalidade.

005 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL

Substância: Cloridrato de Propranolol.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Propranolol, Amprax, Propranolom, Propalol, Pranolal, Iquego - Propranolol, Furp - Propranolol, Sanpronol, Propranolol, Polol

Uso comum

- O cloridrato de propranolol é um betabloqueador que pode aparecer no consultório em pacientes com ansiedade de desempenho, sintomas físicos de ansiedade, enxaqueca, tremor, hipertensão ou outras condições clínicas. Para o terapeuta, o ponto central não é esperar uma mudança elaborativa do humor, mas observar como a redução de sinais corporais de ativação pode alterar a experiência subjetiva, a leitura que o paciente faz de si e sua disponibilidade em sessão. Quando há impacto percebido, ele tende a surgir desde os primeiros dias; por outro lado, cansaço, lentificação ou sono mais pesado também podem aparecer cedo. Vale acompanhar se a sessão fica menos tomada por taquicardia, tremor e rubor, ou se o paciente passa a se sentir mais “apagado”, menos espontâneo ou menos capaz de discriminar estados internos.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade corporal:** Em alguns pacientes, a sessão passa a ter menos marca corporal de ansiedade: menos tremor visível, menos rubor, menos relato de coração acelerado ou sensação de “perder o controle” em situações de exposição. Isso pode ser vivido como alívio real, mas também pode confundir a leitura clínica quando a preocupação antecipatória, a evitação e os pensamentos catastróficos seguem praticamente intactos. Vale observar se houve mudança apenas no corpo, se a autoconfiança aumentou por redução dos sinais físicos, ou se eventos de vida e treino de enfrentamento também ajudam a explicar a melhora.

Cansaço e lentificação: Cansaço, menor vigor, fala um pouco mais lenta ou menor prontidão podem aparecer no setting e ser atribuídos pelo paciente a “desânimo” ou “falta de energia”. Na prática, isso pode se confundir com piora depressiva, privação de sono, sobrecarga clínica ou outras medicações sedativas. A diferença costuma aparecer quando o humor de fundo não piorou na mesma proporção, mas a disposição corporal caiu e certas tarefas passaram a exigir mais esforço do que na linha de base.

Sono e vigília: Alguns pacientes descrevem mais sonolência, sono mais pesado ou sensação de acordar menos descansados, enquanto outros não notam mudança relevante. Em sessão, isso pode surgir como bocejos, menor agilidade associativa ou dificuldade de sustentar atenção, mas também pode refletir rotina desorganizada, uso de álcool, outras medicações ou agravamento do quadro de base. O terapeuta ganha mais precisão quando compara o padrão atual com a semana anterior e com o momento em que o medicamento entrou em cena.

Acesso afetivo: Quando a ativação corporal diminui, parte dos pacientes se sente mais disponível para pensar e falar; outra parte relata uma experiência mais “achatada”, como se a emoção ficasse menos acessível ou menos nítida. Isso pode ser confundido com defesa, embotamento ligado ao quadro depressivo ou simples alívio após semanas de hiperativação fisiológica. Na sessão, importa discriminar se houve redução do sofrimento com preservação da capacidade de elaborar, ou se o paciente parece menos conectado ao próprio afeto e mais difícil de mobilizar clinicamente.

Desempenho e evitação: O propranolol costuma aparecer em histórias marcadas por apresentações, reuniões, provas, entrevistas ou outras situações em que o medo de sinais físicos visíveis pesa tanto quanto a ansiedade em si. Às vezes o paciente passa a se expor mais porque teme menos tremer, corar ou “travar”; em outras, a evitação permanece e apenas muda a expectativa sobre o corpo. Esse ponto é importante porque uma melhora situacional pode parecer avanço global, quando ainda há esquivas, crenças rígidas e sofrimento interpessoal pouco modificados."

O que observar em sessão

- **Ansiedade corporal:** Em alguns pacientes, a sessão passa a ter menos marca corporal de ansiedade: menos tremor visível, menos rubor, menos relato de coração acelerado ou sensação de “perder o controle” em situações de exposição. Isso pode ser vivido como alívio real, mas também pode confundir a leitura clínica quando a preocupação antecipatória, a evitação e os pensamentos catastróficos seguem praticamente intactos. Vale observar se houve mudança apenas no corpo, se a autoconfiança aumentou por redução dos sinais físicos, ou se eventos de vida e treino de enfrentamento também ajudam a explicar a melhora.

Cansaço e lentificação: Cansaço, menor vigor, fala um pouco mais lenta ou menor prontidão podem aparecer no setting e ser atribuídos pelo paciente a “desânimo” ou “falta de energia”. Na prática, isso pode se confundir com piora depressiva, privação de sono, sobrecarga clínica ou outras medicações sedativas. A diferença costuma aparecer quando o humor de fundo não piorou na mesma proporção, mas a disposição corporal caiu e certas tarefas passaram a exigir mais esforço do que na linha de base.

Sono e vigília: Alguns pacientes descrevem mais sonolência, sono mais pesado ou sensação de acordar menos descansados, enquanto outros não notam mudança relevante. Em sessão, isso pode surgir como bocejos, menor agilidade associativa ou dificuldade de sustentar atenção, mas também pode refletir rotina desorganizada, uso de álcool, outras medicações ou agravamento do quadro de base. O terapeuta ganha mais precisão quando compara o padrão atual com a semana anterior e com o momento em que o medicamento entrou em cena.

Acesso afetivo: Quando a ativação corporal diminui, parte dos pacientes se sente mais disponível para pensar e falar; outra parte relata uma experiência mais “achatada”, como se a emoção ficasse menos acessível ou menos nítida. Isso pode ser confundido com defesa, embotamento ligado ao quadro depressivo ou simples alívio após semanas de hiperativação fisiológica. Na sessão, importa discriminar se houve redução do sofrimento com preservação da capacidade de elaborar, ou se o paciente parece menos conectado ao próprio afeto e mais difícil de mobilizar clinicamente.

Desempenho e evitação: O propranolol costuma aparecer em histórias marcadas por apresentações, reuniões, provas, entrevistas ou outras situações em que o medo de sinais físicos visíveis pesa tanto quanto a ansiedade em si. Às vezes o paciente passa a se expor mais porque teme menos tremer, corar ou “travar”; em outras, a evitação permanece e apenas muda a expectativa sobre o corpo. Esse ponto é importante porque uma melhora situacional pode parecer avanço global, quando ainda há esquivas, crenças rígidas e sofrimento interpessoal pouco modificados.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O cloridrato de propranolol é um betabloqueador que pode aparecer no consultório em pacientes com ansiedade de desempenho, sintomas físicos de ansiedade, enxaqueca, tremor, hipertensão ou outras condições clínicas. Para o terapeuta, o ponto central não é esperar uma mudança elaborativa do humor, mas observar como a redução de sinais corporais de ativação pode alterar a experiência subjetiva, a leitura que o paciente faz de si e sua disponibilidade em sessão. Quando há impacto percebido, ele tende a surgir desde os primeiros dias; por outro lado, cansaço, lentificação ou sono mais pesado também podem aparecer cedo. Vale acompanhar se a sessão fica menos tomada por taquicardia, tremor e rubor, ou se o paciente passa a se sentir mais “apagado”, menos espontâneo ou menos capaz de discriminar estados internos.

Perguntas úteis

- "Quando você se sentiu melhor, o que mudou mais: os pensamentos de ameaça, a vontade de evitar ou principalmente as reações do corpo? , Esse cansaço vem junto com tristeza, culpa e perda de interesse, ou parece mais uma queda de energia física com o restante relativamente parecido? , Nas situações que antes disparavam ansiedade, você passou a entrar mais nelas ou continua evitando, só que com menos medo dos sinais no corpo? , Quando você diz que está mais “frio” ou “apagado”, isso parece alívio por não ficar tão tomado pela ansiedade ou uma dificuldade nova de sentir e nomear o que acontece com você? , A piora de atenção ou sonolência apareceu junto com a entrada do remédio e se mantém parecida ao longo dos dias, ou varia mais conforme sono, rotina e estresse?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar cansaço
- lentificação ou sonolência que interferem de modo claro no trabalho
- nos estudos ou na própria participação na terapia
- pode valer alinhar com o médico assistente para qualificar o impacto funcional e a temporalidade do quadro
- Quando há melhora dos sinais físicos de ansiedade
- mas a evitação
- o sofrimento antecipatório e o prejuízo subjetivo seguem altos
- pode valer comunicar ao médico para situar que a resposta percebida é parcial e predominantemente corporal
- Quando o paciente reduz por conta própria o uso em dias de exposição
- alterna tomadas de forma irregular ou abandona silenciosamente por se sentir “apagado”
- pode valer alinhar com o médico para registrar adesão irregular e seus motivos
- Quando surgem tontura
- sensação de fraqueza ou quase desmaio associadas ao uso e isso aparece também na sessão ou na rotina
- pode valer comunicar ao médico assistente pela repercussão clínica e funcional
- Quando o paciente em uso para ansiedade de desempenho passa a ampliar exposições

Amarelo: alinhar em breve

- mas com custo psíquico ainda alto e oscilante
- pode valer contato com o médico para integrar a leitura entre redução de sintomas físicos e manutenção do núcleo ansioso

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente relata ou apresenta desmaio
- queda com perda de consciência
- falta de ar importante ou dor no peito em contexto próximo ao uso.: Interromper o trabalho psicoterápico naquele momento e acionar avaliação médica imediata
- emergência ou rede de apoio conforme o contexto
- Surge rebaixamento importante do estado geral
- com confusão
- extrema fraqueza ou dificuldade marcante de se manter responsivo durante a sessão.: Priorizar segurança
- não deixar o paciente sozinho e providenciar avaliação médica no mesmo dia
- com acionamento de emergência se necessário

Frase clínica

O foco clínico é distinguir redução da ansiedade corporal de mudança mais ampla no padrão ansioso e no funcionamento do paciente.

006 PROMETAZINA

Substância: Prometazina.

Nomes Comerciais: Cremefenergan

Uso comum

- Prometazina é um anti-histamínico com efeito sedativo, encontrado com mais frequência em contextos de alergia, náusea, coceira ou uso pontual para dormir. No consultório, tende a importar menos pela indicação e mais pelo modo como altera o estado de vigília, a atenção e o ritmo da sessão. Quando usada de forma eventual, o impacto costuma aparecer no mesmo dia ou na manhã seguinte; em uso mais contínuo, vale observar se a lentificação se estabiliza ou passa a interferir na rotina. O ponto central é discriminar sonolência medicamentosa de piora depressiva, exaustão acumulada, uso de outras substâncias ou adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** A sessão pode ficar mais lenta, com fala arrastada, bocejos, menor iniciativa associativa e dificuldade de sustentar elaboração. Isso pode se confundir com humor deprimido, privação de sono, ressaca de álcool, uso de benzodiazepínicos ou simplesmente um horário do dia em que o paciente já costuma chegar esgotado. Vale comparar com a linha de base e com o momento em que a medicação foi usada, sobretudo quando o paciente a toma de forma eventual.

Atenção e cognição: Alguns pacientes descrevem cabeça pesada, raciocínio menos ágil, lapsos de atenção e sensação de estar meio desligado. Na sessão, isso pode aparecer como perda do fio, respostas mais concretas ou dificuldade de acessar nuances afetivas, o que às vezes parece resistência ou empobrecimento psíquico quando pode haver componente farmacológico. Também convém considerar dor, quadro alérgico em curso, noites mal dormidas e outras medicações sedativas na leitura clínica.

Sono e ritmo: Quando entra em cena por causa do sono, a prometazina pode melhorar a indução do adormecer em alguns casos, mas também deixar um resíduo de sonolência no dia seguinte. O terapeuta pode encontrar um paciente que dormiu mais horas, porém acordou pouco restaurado, o que se diferencia de insônia persistente ou de sono fragmentado por ansiedade ao explorar a qualidade do despertar e o padrão ao longo da semana. Se o uso é intermitente, oscilações entre noites muito diferentes podem refletir mais o padrão de tomada do que mudança do quadro de base.

Adesão e uso situacional: Por ser um medicamento muitas vezes usado quando precisa, o padrão de uso pode ficar pouco integrado ao relato espontâneo do paciente. Isso favorece leituras equivocadas de oscilação clínica, especialmente quando a pessoa alterna dias de maior lentificação com dias de funcionamento habitual sem nomear que tomou algo na véspera. Na prática, vale observar se há uso silencioso para dormir, para aliviar desconforto físico ou em combinação com álcool e outros sedativos, porque isso muda bastante a leitura da sessão."

O que observar em sessão

- **Sedação:** A sessão pode ficar mais lenta, com fala arrastada, bocejos, menor iniciativa associativa e dificuldade de sustentar elaboração. Isso pode se confundir com humor deprimido, privação de sono, ressaca de álcool, uso de benzodiazepínicos ou simplesmente um horário do dia em que o paciente já costuma chegar esgotado. Vale comparar com a linha de base e com o momento em que a medicação foi usada, sobretudo quando o paciente a toma de forma eventual.

Atenção e cognição: Alguns pacientes descrevem cabeça pesada, raciocínio menos ágil, lapsos de atenção e sensação de estar "meio desligado". Na sessão, isso pode aparecer como perda do fio, respostas mais concretas ou dificuldade de acessar nuances afetivas, o que às vezes parece resistência ou empobrecimento psíquico quando pode haver componente farmacológico. Também convém considerar dor, quadro alérgico em curso, noites mal dormidas e outras medicações sedativas na leitura clínica.

Sono e ritmo: Quando entra em cena por causa do sono, a prometazina pode melhorar a indução do adormecer em alguns casos, mas também deixar um resíduo de sonolência no dia seguinte. O terapeuta pode encontrar um paciente que dormiu mais horas, porém acordou pouco restaurado, o que se diferencia de insônia persistente ou de sono fragmentado por ansiedade ao explorar a qualidade do despertar e o padrão ao longo da semana. Se o uso é intermitente, oscilações entre noites muito diferentes podem refletir mais o padrão de tomada do que mudança do quadro de base.

Adesão e uso situacional: Por ser um medicamento muitas vezes usado "quando precisa", o padrão de uso pode ficar pouco integrado ao relato espontâneo do paciente. Isso favorece leituras equivocadas de oscilação clínica, especialmente quando a pessoa alterna dias de maior lentificação com dias de funcionamento habitual sem nomear que tomou algo na véspera. Na prática, vale observar se há uso silencioso para dormir, para aliviar desconforto físico ou em combinação com álcool e outros sedativos, porque isso muda bastante a leitura da sessão.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Prometazina é um anti-histamínico com efeito sedativo, encontrado com mais frequência em contextos de alergia, náusea, coceira ou uso pontual para dormir. No consultório, tende a importar menos pela indicação e mais pelo modo como altera o estado de vigília, a atenção e o ritmo da sessão. Quando usada de forma eventual, o impacto costuma aparecer no mesmo dia ou na manhã seguinte; em uso mais contínuo, vale observar se a lentificação se estabiliza ou passa a interferir na rotina. O ponto central é discriminar sonolência medicamentosa de piora depressiva, exaustão acumulada, uso de outras substâncias ou adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Nos dias em que você fica mais lento ou sonolento, isso começou depois de usar a medicação ou já vinha acontecendo mesmo sem ela? , Quando você acorda mais apagado, a sensação é de ter dormido e ainda assim não despertar bem, ou de ter passado a noite ruim e chegar exausto por isso? , Essa dificuldade de se concentrar aparece de modo parecido ao longo da semana ou fica mais marcada em dias específicos, como depois de tomar algo para alergia ou para dormir? , Quando você se percebe menos responsivo na sessão, isso vem junto com tristeza, desesperança e retraimento, ou parece mais um corpo pesado e uma mente embotada sem mudança clara do humor? , Você costuma usar essa medicação de forma planejada ou mais no impulso, conforme o desconforto aparece, e o que muda no dia seguinte quando usa?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- Identificado ou cognitivamente prejudicado
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se há impacto funcional relevante do uso
- Quando surge uso frequente e pouco nomeado como recurso para dormir ou "desligar"
- pode valer comunicar para avaliação do padrão de uso e do risco de manutenção silenciosa do problema de base
- Quando a sedação parece se somar a álcool
- benzodiazepínicos ou outros agentes sedativos referidos em sessão
- pode valer contato com o médico pela maior dificuldade de discriminar origem dos sintomas e pelo potencial de prejuízo funcional
- Quando o paciente relata pouca melhora do desconforto que motivou o uso
- mas mantém sonolência importante
- pode valer alinhar com o médico para reavaliar a relação entre benefício percebido e custo subjetivo

Vermelho: tratar como urgência

- Paciente muito rebaixado
- confuso
- difícil de despertar ou com fala tão prejudicada que a sessão não se sustenta com segurança
- especialmente se houver relato de álcool ou outros sedativos no mesmo período.: Interromper a exploração psicoterápica
- avaliar segurança imediata
- acionar rede de apoio e buscar avaliação médica no mesmo dia; emergência
- se necessário
- Aparecimento durante a sessão de agitação intensa

Vermelho: tratar como urgência

- desorientação importante ou piora abrupta do estado mental fora do padrão habitual.: Tratar como alteração aguda do estado clínico
- priorizar avaliação médica imediata e acionar suporte presencial ou emergência conforme o contexto

Frase clínica

O foco clínico é distinguir sedação e lentificação ligadas ao uso situacional de piora do humor, exaustão e uso combinado de outras substâncias.

007 FUMARATO DE CLEMASTINA; ACETATO DE DEXAMETASONA

Substância: Fumarato de Clemastina; Acetato de Dexametasona.

Nomes Comerciais: Emistin

Uso comum

- Associação tópica de anti-histamínico com corticosteroide, usada em quadros dermatológicos inflamatórios e pruriginosos. No consultório de terapia, o foco raramente é o produto em si, mas o impacto do problema de pele e do tratamento sobre sono, irritabilidade, exposição do corpo e rotina de autocuidado. Se houver absorção sistêmica relevante ou uso mais prolongado do que o previsto, mudanças de humor, agitação ou piora do sono podem surgir em dias a poucas semanas, embora isso nem sempre seja fácil de separar do desconforto físico e do estresse associado à condição. Vale acompanhar a linha de base emocional e o quanto a pele passa a organizar a vida psíquica do paciente.

O paciente pode relatar

- **"Sono e coceira:** Prurido, ardor e desconforto cutâneo podem fragmentar o sono e deixar o paciente mais irritável, disperso ou com menor tolerância afetiva na sessão. Quando a queixa aparece junto de piora noturna da coceira, o quadro costuma se explicar mais pelo sofrimento físico do que por uma mudança primária de humor. Se a alteração do sono surge sem relação clara com os sintomas de pele, especialmente após início recente do tratamento, vale manter em mente também a hipótese de efeito sistêmico ou coincidência com estressores externos.

Humor e reatividade: Alguns pacientes chegam mais tensos, impacientes ou emocionalmente reativos, mas isso pode decorrer tanto do desconforto corporal e da frustração com a persistência das lesões quanto de eventual efeito do corticosteroide quando há maior exposição sistêmica. Na sessão, ajuda observar se a irritabilidade acompanha piora da pele, vergonha, dor ou privação de sono, ou se aparece como mudança mais abrupta do padrão habitual. Oscilações sem lastro claro na evolução dermatológica merecem registro mais fino, sobretudo nas primeiras semanas de uso.

Imagem corporal: Lesões visíveis, coceira e marcas na pele podem aumentar evitação social, constrangimento, hipervigilância ao olhar do outro e retraimento sexual ou afetivo. Às vezes o paciente atribui toda a mudança emocional ao medicamento, quando o que se impõe é o impacto subjetivo da doença de pele sobre autoestima e identidade. Na sessão, costuma ser mais útil discriminar o peso da exposição corporal, do medo de julgamento e das limitações práticas do tratamento do que buscar uma leitura exclusivamente farmacológica.

Adesão e manejo: Em tratamentos tópicos, a adesão irregular é comum e pode confundir a leitura clínica: o paciente melhora, interrompe, piora, retoma e passa a viver isso como instabilidade emocional ou fracasso pessoal. Também pode haver uso mais frequente do que o combinado, por urgência em aliviar sintomas, sem que isso apareça espontaneamente no relato. Vale observar se a narrativa de piora coincide com mudanças no modo de usar, abandono silencioso por incômodo ou expectativas muito altas de resolução rápida."

O que observar em sessão

- **Sono e coceira:** Prurido, ardor e desconforto cutâneo podem fragmentar o sono e deixar o paciente mais irritável, disperso ou com menor tolerância afetiva na sessão. Quando a queixa aparece junto de piora noturna da coceira, o quadro costuma se explicar mais pelo sofrimento físico do que por uma mudança primária de humor. Se a alteração do sono surge sem relação clara com os sintomas de pele, especialmente após início recente do tratamento, vale manter em mente também a hipótese de efeito sistêmico ou coincidência com estressores externos.

Humor e reatividade: Alguns pacientes chegam mais tensos, impacientes ou emocionalmente reativos, mas isso pode decorrer tanto do desconforto corporal e da frustração com a persistência das lesões quanto de eventual efeito do corticosteroide quando há maior exposição sistêmica. Na sessão, ajuda observar se a irritabilidade acompanha piora da pele, vergonha, dor ou privação de sono, ou se aparece como mudança mais abrupta do padrão habitual. Oscilações sem lastro claro na evolução dermatológica merecem registro mais fino, sobretudo nas primeiras semanas de uso.

Imagem corporal: Lesões visíveis, coceira e marcas na pele podem aumentar evitação social, constrangimento, hipervigilância ao olhar do outro e retraimento sexual ou afetivo. Às vezes o paciente atribui toda a mudança emocional ao medicamento, quando o que se impõe é o impacto subjetivo da doença de pele sobre autoestima e identidade. Na sessão, costuma ser mais útil discriminar o peso da exposição corporal, do medo de julgamento e das limitações práticas do tratamento do que buscar uma leitura exclusivamente farmacológica.

Adesão e manejo: Em tratamentos tópicos, a adesão irregular é comum e pode confundir a leitura clínica: o paciente melhora, interrompe, piora, retoma e passa a viver isso como instabilidade emocional ou fracasso pessoal. Também pode haver uso mais frequente do que o combinado, por urgência em aliviar sintomas, sem que isso apareça espontaneamente no relato. Vale observar se a narrativa de piora coincide com mudanças no modo de usar, abandono silencioso por incômodo ou expectativas muito altas de resolução rápida.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Associação tópica de anti-histamínico com corticosteroide, usada em quadros dermatológicos inflamatórios e pruriginosos. No consultório de terapia, o foco raramente é o produto em si, mas o impacto do problema de pele e do tratamento sobre sono, irritabilidade, exposição do corpo e rotina de autocuidado. Se houver absorção sistêmica relevante ou uso mais prolongado do que o previsto, mudanças de humor, agitação ou piora do sono podem surgir em dias a poucas semanas, embora isso nem sempre seja fácil de separar do desconforto físico e do estresse associado à condição. Vale acompanhar a linha de base emocional e o quanto a pele passa a organizar a vida psíquica do paciente.

Perguntas úteis

- "Quando seu humor piora, isso costuma vir junto com mais coceira, ardor ou noites mal dormidas, ou aparece mesmo quando a pele está parecida? , Você percebe que o incômodo maior tem sido o efeito da pele no seu dia a dia e na forma como se sente visto, ou uma mudança interna mais abrupta no seu jeito de estar? , Nas últimas semanas, a oscilação dos sintomas acompanhou um uso regular do tratamento ou houve períodos em que você interrompeu, esqueceu ou usou de um jeito diferente? , Quando você se sente mais irritado ou acelerado, isso parece reação ao desconforto e à frustração com a pele, ou algo que surge desproporcionalmente ao que está acontecendo no corpo?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta mudança de humor
- agitação ou insônia novas e relativamente abruptas após início recente ou uso mais intenso do produto
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a contribuição do tratamento e da condição de base
- Quando a adesão oscila bastante
- com interrupções e retomadas frequentes que confundem a leitura da evolução clínica
- pode valer comunicar o médico para esclarecer o contexto do uso
- Quando o sofrimento com a pele passa a produzir retraimento importante
- vergonha intensa ou prejuízo funcional persistente
- pode valer alinhar com o médico para reavaliar a evolução do quadro dermatológico
- Quando o paciente relata uso mais amplo
- mais frequente ou por tempo maior do que o inicialmente previsto
- pode valer contato com o médico pela possibilidade de maior exposição sistêmica e pela dificuldade de manejo autônomo

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecimento de ideação suicida
- desesperança intensa ou fala de não suportar mais o quadro
- independentemente da causa parecer ligada à pele ou ao tratamento.: Fazer avaliação de risco na hora e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Mudança abrupta com agitação intensa
- redução importante da necessidade de sono
- impulsividade ou desorganização comportamental fora do padrão habitual.: Tratar como urgência clínica
- contatar o médico no mesmo dia e acionar suporte adicional conforme o grau de risco

Frase clínica

Nesta associação tópica, o essencial é diferenciar sofrimento pela condição de pele de mudanças emocionais que surgem junto ao tratamento.

008 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA

Substância: Fosfato Sódico de Prednisolona.

Nomes Comerciais: Fosfato Sódico de Prednisolona, Preni, Percoide, Ems-Pred, Fosfato Sodico de Prednisolona, Prosolin, Zastat, Prelone, Predsigma, Predsim, Predsim Odt

Uso comum

- O fosfato sódico de prednisolona é um corticoide sistêmico que costuma aparecer em pacientes em tratamento de crises inflamatórias, alérgicas, respiratórias, dermatológicas ou autoimunes. No consultório, o mais útil é acompanhar mudanças que surgem logo nos primeiros dias de uso ou após aumentos recentes de exposição: ativação, irritabilidade, piora do sono, oscilação de humor e, em alguns casos, sensação de aceleração mental. Em uso mais prolongado, podem ganhar peso a fadiga subjetiva, alterações de imagem corporal e desgaste com o tratamento. A leitura clínica pede comparação com a linha de base, com a doença de base e com o contexto de vida, porque melhora física e custo psíquico podem caminhar juntos.

O paciente pode relatar

- **"Humor reativo:** Alguns pacientes chegam mais irritáveis, impacientes ou emocionalmente lábeis poucos dias após iniciar o corticoide, às vezes com desproporção entre gatilho e intensidade da reação. Na sessão, isso pode aparecer como menor tolerância à frustração, aumento de conflito interpessoal ou choro fácil sem elaboração correspondente. Convém não tomar essa mudança como simples agravamento do quadro psíquico prévio sem comparar com a linha de base, com a melhora ou piora da condição clínica que motivou o uso e com estressores recentes fora do consultório.

Ativação e sono: Pode surgir um estado de aceleração subjetiva: mais energia, inquietação, fala mais rápida ou dificuldade de desacelerar à noite, especialmente no início do tratamento. Em sessão, isso às vezes se confunde com alívio legítimo por melhora física, com ansiedade habitual ou com um funcionamento mais expansivo que já fazia parte do paciente. A discriminação depende de observar temporalidade, perda de necessidade de sono, mudança no ritmo da fala e se há sensação de bem-estar estável ou desconforto por estar "ligado demais".

Ansiedade corporal: Parte dos pacientes descreve nervosismo, tensão interna ou sensação de estar "elétrico", mais corporal do que ligada a pensamentos específicos. O terapeuta pode notar inquietação motora, dificuldade de permanecer em um tema e menor capacidade de autorregulação durante a sessão. Isso pode ser lido apressadamente como ansiedade psicodinâmica, resposta a eventos de vida ou piora do transtorno de base, quando às vezes a pista principal está na coincidência temporal com o tratamento e na qualidade mais somática da experiência.

Imagem corporal: Quando o uso se prolonga, mudanças corporais percebidas, aumento de apetite ou retenção podem afetar autoestima, sexualidade e disposição para exposição social. Na sessão, o paciente pode aparecer mais autoconsciente, envergonhado ou evitando situações antes toleráveis, mesmo quando a condição médica está melhor controlada. Vale diferenciar sofrimento ligado à imagem corporal de humor depressivo mais amplo, e também notar quando a adesão fica ameaçada por incômodo silencioso com o próprio corpo.

Carga do tratamento: Como costuma ser usado em contextos de doença aguda ou crônica com impacto concreto na rotina, o medicamento frequentemente entra na sessão menos pelo nome e mais pelo que reorganiza: consultas, sintomas físicos, medo de recaída e sensação de perda de autonomia. O trabalho terapêutico pode ficar temporariamente mais concreto e menos elaborativo, com foco em suportar imprevisibilidade e dependência de cuidados. Isso não deve ser confundido automaticamente com empobrecimento psíquico; muitas vezes reflete a centralidade real da condição clínica naquele período."

O que observar em sessão

- **Humor reativo:** Alguns pacientes chegam mais irritáveis, impacientes ou emocionalmente lábeis poucos dias após iniciar o corticoide, às vezes com desproporção entre gatilho e intensidade da reação. Na sessão, isso pode aparecer como menor tolerância à frustração, aumento de conflito interpessoal ou choro fácil sem elaboração correspondente. Convém não tomar essa mudança como simples agravamento do quadro psíquico prévio sem comparar com a linha de base, com a melhora ou piora da condição clínica que motivou o uso e com estressores recentes fora do consultório.

Ativação e sono: Pode surgir um estado de aceleração subjetiva: mais energia, inquietação, fala mais rápida ou dificuldade de desacelerar à noite, especialmente no início do tratamento. Em sessão, isso às vezes se confunde com alívio legítimo por melhora física, com ansiedade habitual ou com um funcionamento mais expansivo que já fazia parte do paciente. A discriminação depende de observar temporalidade, perda de necessidade de sono, mudança no ritmo da fala e se há sensação de bem-estar estável ou desconforto por estar “ligado demais”.

Ansiedade corporal: Parte dos pacientes descreve nervosismo, tensão interna ou sensação de estar “elétrico”, mais corporal do que ligada a pensamentos específicos. O terapeuta pode notar inquietação motora, dificuldade de permanecer em um tema e menor capacidade de autorregulação durante a sessão. Isso pode ser lido apressadamente como ansiedade psicodinâmica, resposta a eventos de vida ou piora do transtorno de base, quando às vezes a pista principal está na coincidência temporal com o tratamento e na qualidade mais somática da experiência.

Imagem corporal: Quando o uso se prolonga, mudanças corporais percebidas, aumento de apetite ou retenção podem afetar autoestima, sexualidade e disposição para exposição social. Na sessão, o paciente pode aparecer mais autoconsciente, envergonhado ou evitando situações antes toleráveis, mesmo quando a condição médica está melhor controlada. Vale diferenciar sofrimento ligado à imagem corporal de humor depressivo mais amplo, e também notar quando a adesão fica ameaçada por incômodo silencioso com o próprio corpo.

Carga do tratamento: Como costuma ser usado em contextos de doença aguda ou crônica com impacto concreto na rotina, o medicamento frequentemente entra na sessão menos pelo nome e mais pelo que reorganiza: consultas, sintomas físicos, medo de recaída e sensação de perda de autonomia. O trabalho terapêutico pode ficar temporariamente mais concreto e menos elaborativo, com foco em suportar imprevisibilidade e dependência de cuidados. Isso não deve ser confundido automaticamente com empobrecimento psíquico; muitas vezes reflete a centralidade real da condição clínica naquele período.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O fosfato sódico de prednisolona é um corticoide sistêmico que costuma aparecer em pacientes em tratamento de crises inflamatórias, alérgicas, respiratórias, dermatológicas ou autoimunes. No consultório, o mais útil é acompanhar mudanças que surgem logo nos primeiros dias de uso ou após aumentos recentes de exposição: ativação, irritabilidade, piora do sono, oscilação de humor e, em alguns casos, sensação de aceleração mental. Em uso mais prolongado, podem ganhar peso a fadiga subjetiva, alterações de imagem corporal e desgaste com o tratamento. A leitura clínica pede comparação com a linha de base, com a doença de base e com o contexto de vida, porque melhora física e custo psíquico podem caminhar juntos.

Perguntas úteis

- "Essas mudanças de humor ou irritação começaram antes do tratamento, junto com o início dele, ou depois de alguma situação específica da sua vida? , Quando você se sente mais acelerado, isso vem com sensação boa de disposição ou com incômodo por não conseguir desacelerar e dormir? , Essa inquietação parece ligada a pensamentos e preocupações identificáveis, ou é mais uma agitação no corpo que aparece mesmo sem um motivo claro? , Você sente que está dormindo menos porque está sem sono e continua funcionando, ou dormindo mal e ficando mais cansado e irritado no dia seguinte? , O desconforto com o corpo mudou seu desejo de se relacionar e se expor, ou ele vem junto de uma queda mais geral de interesse e prazer?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta irritabilidade
- aceleração ou redução importante do sono que surgiram nos primeiros dias de uso
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a mudança no contexto do tratamento atual
- Quando a ansiedade corporal ou a inquietação ficam intensas a ponto de atrapalhar o vínculo
- o trabalho em sessão ou a rotina
- pode valer comunicar para avaliação da tolerabilidade clínica
- Quando o paciente começa a cogitar interromper por conta própria por incômodo com humor
- sono ou mudanças corporais
- pode valer contato com o médico para reduzir risco de abandono silencioso
- Quando não há melhora subjetiva global porque a condição física melhora
- mas o custo psíquico cresce de forma marcada
- pode valer alinhar com o médico assistente para integrar a leitura clínica
- Quando surgem sinais de expansão incomum do humor
- impulsividade ou sensação de precisar muito menos de sono do que o habitual
- pode valer comunicar pela possibilidade de mudança de estado que merece avaliação médica

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- surge ideação suicida nova ou claramente intensificada
- especialmente em associação temporal com início recente do tratamento ou piora importante do sono e da agitação.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário
- O paciente aparece muito acelerado
- dormindo muito menos que o habitual
- com fala pressionada
- impulsividade ou grandiosidade incomum para seu padrão.: Tratar como mudança aguda de estado
- contatar o médico assistente no mesmo dia e avaliar necessidade de apoio emergencial

Frase clínica

Nos corticoides, o foco é datar mudanças rápidas de humor, sono e ativação sem perder de vista a doença de base e a carga do tratamento.

009 PREDNISOLONA

Substância: Prednisolona.

Nomes Comerciais: Prednisolona, Pred-Gran

Uso comum

- Prednisolona é um corticoide sistêmico que costuma aparecer em pacientes em tratamento de condições inflamatórias, alérgicas ou autoimunes. No consultório, o ponto central não é apenas o medicamento, mas a combinação entre doença de base, impacto corporal do tratamento e possíveis mudanças de humor, sono e nível de ativação. Alterações subjetivas podem surgir já nos primeiros dias ou na primeira semana, especialmente no início ou após mudanças recentes no esquema, enquanto o peso psíquico da condição clínica pode se prolongar por semanas a meses. Vale acompanhar a linha de base anterior ao início, a coincidência temporal entre mudanças clínicas e uso, e a regularidade da tomada.

O paciente pode relatar

- **"Humor reativo:** Alguns pacientes chegam mais irritáveis, expansivos, chorosos ou emocionalmente lábeis, às vezes com sensação de estar "diferente de si". Na sessão, isso pode aparecer como menor tolerância à frustração, aumento de conflitos interpessoais ou reatividade desproporcional a temas habituais. A leitura pode se confundir com estresse pela doença de base, dor, privação de sono ou eventos de vida recentes; por isso, ajuda comparar com o padrão afetivo anterior e com o momento em que essas mudanças começaram.

Ativação e agitação: Pode haver aceleração subjetiva, inquietação, fala mais rápida, dificuldade de desacelerar e sensação de energia excessiva sem bem-estar correspondente. Em sessão, isso às vezes se parece com ansiedade habitual, mas também pode destoar da baseline do paciente por surgir de modo mais abrupto e corporalmente marcado. Convém diferenciar de alívio legítimo por melhora clínica da condição médica, de traços temperamentais prévios e do uso concomitante de outras medicações estimulantes.

Sono: Insônia inicial, sono mais leve ou sensação de cansaço sem conseguir repousar podem alterar bastante o material da sessão. O paciente pode ficar mais impaciente, menos reflexivo e com acesso afetivo empobrecido simplesmente por noites ruins, o que pode ser confundido com piora ansiosa ou depressiva. Vale observar se a mudança no sono apareceu junto com o tratamento, se oscila conforme a rotina da doença e se a fadiga diurna decorre de pouco sono ou de abatimento do quadro de base.

Ansiedade: Em parte dos casos, surge tensão interna, sensação de alerta excessivo ou apreensão difusa que o paciente descreve como diferente da sua ansiedade usual. Na sessão, isso pode aparecer como hipervigilância corporal, dificuldade de permanecer em silêncio e maior foco em sensações físicas. A distinção clínica importante é entre ansiedade ligada ao contexto médico real, medo de piora da doença, efeitos corporais do tratamento e recrudescimento de um transtorno ansioso prévio.

Imagem corporal: Quando o uso se prolonga, mudanças corporais percebidas, inchaço, ganho de peso ou alteração da aparência podem ganhar relevo emocional e relacional. O paciente pode trazer vergonha, retraimento social, queda de autoestima ou sensação de não reconhecimento do próprio corpo, o que interfere no vínculo, na sexualidade e na disposição para sair de casa. Isso pode ser atribuído apressadamente a depressão, quando às vezes está mais ligado ao impacto identitário do tratamento e da condição clínica."

O que observar em sessão

- **Humor reativo:** Alguns pacientes chegam mais irritáveis, expansivos, chorosos ou emocionalmente lábeis, às vezes com sensação de estar “diferente de si”. Na sessão, isso pode aparecer como menor tolerância à frustração, aumento de conflitos interpessoais ou reatividade desproporcional a temas habituais. A leitura pode se confundir com estresse pela doença de base, dor, privação de sono ou eventos de vida recentes; por isso, ajuda comparar com o padrão afetivo anterior e com o momento em que essas mudanças começaram.

Ativação e agitação: Pode haver aceleração subjetiva, inquietação, fala mais rápida, dificuldade de desacelerar e sensação de energia excessiva sem bem-estar correspondente. Em sessão, isso às vezes se parece com ansiedade habitual, mas também pode destoar da baseline do paciente por surgir de modo mais abrupto e corporalmente marcado. Convém diferenciar de alívio legítimo por melhora clínica da condição médica, de traços temperamentais prévios e do uso concomitante de outras medicações estimulantes.

Sono: Insônia inicial, sono mais leve ou sensação de cansaço sem conseguir repousar podem alterar bastante o material da sessão. O paciente pode ficar mais impaciente, menos reflexivo e com acesso afetivo empobrecido simplesmente por noites ruins, o que pode ser confundido com piora ansiosa ou depressiva. Vale observar se a mudança no sono apareceu junto com o tratamento, se oscila conforme a rotina da doença e se a fadiga diurna decorre de pouco sono ou de abatimento do quadro de base.

Ansiedade: Em parte dos casos, surge tensão interna, sensação de alerta excessivo ou apreensão difusa que o paciente descreve como diferente da sua ansiedade usual. Na sessão, isso pode aparecer como hipervigilância corporal, dificuldade de permanecer em silêncio e maior foco em sensações físicas. A distinção clínica importante é entre ansiedade ligada ao contexto médico real, medo de piora da doença, efeitos corporais do tratamento e recrudescimento de um transtorno ansioso prévio.

Imagem corporal: Quando o uso se prolonga, mudanças corporais percebidas, inchaço, ganho de peso ou alteração da aparência podem ganhar relevo emocional e relacional. O paciente pode trazer vergonha, retraimento social, queda de autoestima ou sensação de não reconhecimento do próprio corpo, o que interfere no vínculo, na sexualidade e na disposição para sair de casa. Isso pode ser atribuído apressadamente a depressão, quando às vezes está mais ligado ao impacto identitário do tratamento e da condição clínica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Prednisolona é um corticoide sistêmico que costuma aparecer em pacientes em tratamento de condições inflamatórias, alérgicas ou autoimunes. No consultório, o ponto central não é apenas o medicamento, mas a combinação entre doença de base, impacto corporal do tratamento e possíveis mudanças de humor, sono e nível de ativação. Alterações subjetivas podem surgir já nos primeiros dias ou na primeira semana, especialmente no início ou após mudanças recentes no esquema, enquanto o peso psíquico da condição clínica pode se prolongar por semanas a meses. Vale acompanhar a linha de base anterior ao início, a coincidência temporal entre mudanças clínicas e uso, e a regularidade da tomada.

Perguntas úteis

- "Essas mudanças de humor ou irritação começaram antes do tratamento, junto com ele, ou depois de algum outro acontecimento importante? , Quando você se sente mais acelerado, isso vem com sensação de bem-estar e clareza ou com incômodo, inquietação e dificuldade de se conter? , O cansaço que aparece hoje parece vir de tristeza e desânimo ou de noites ruins e dificuldade de desligar? , Essa ansiedade se parece com a que você já conhecia em outros momentos da vida ou tem uma qualidade mais corporal, de alerta e agitação? , O afastamento social recente tem mais a ver com perda de interesse pelas pessoas ou com desconforto com seu corpo e com a forma como você acha que está sendo visto?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a apresentar irritabilidade intensa
- aceleração incomum ou redução importante da necessidade de sono após início recente do tratamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a mudança no contexto clínico atual
- Quando a ansiedade ou a agitação ficam suficientemente marcadas a ponto de comprometer o trabalho
- o convívio ou a continuidade da psicoterapia
- pode valer comunicar para avaliação da tolerabilidade no tratamento em curso
- Quando surgem alterações de humor relevantes em paciente com história pessoal ou familiar de bipolaridade
- pode valer contato com o médico para melhor discriminar vulnerabilidade do quadro de base e mudança associada ao tratamento
- Quando o paciente relata uso irregular
- interrupções por conta própria ou abandono silencioso por incômodo com efeitos percebidos
- pode valer alinhar com o médico porque a adesão passa a ser parte central da leitura clínica
- Quando mudanças corporais percebidas passam a produzir retraimento importante
- vergonha intensa ou sofrimento persistente
- pode valer comunicação para contextualizar o impacto psíquico do tratamento e da condição médica

Vermelho: tratar como urgência

- Surge ideação suicida nova
- intensificada ou acompanhada de impulsividade
- desespero ou sensação de perda de controle.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário
- O paciente chega muito acelerado

Vermelho: tratar como urgência

- com fala pressionada
- quase sem dormir
- grandiosidade incomum ou comportamento claramente fora do seu padrão.: Tratar como mudança aguda de estado mental
- contatar o médico no mesmo dia e acionar suporte adicional se houver risco comportamental

Frase clínica

Com prednisolona, o foco é datar mudanças rápidas de humor, sono e ativação sem perder de vista o peso psíquico da doença de base.

010 PREDNISONA

Substância: Prednisona.

Nomes Comerciais: Meticorten, Prednisona, Ciclorten, Crispred, Predcort, Flamape, Nisbal, Corticorten, Predinis

Uso comum

- Prednisona é um corticosteroide sistêmico usado em quadros inflamatórios, alérgicos e autoimunes, e às vezes aparece no consultório sem que o foco inicial do tratamento seja psiquiátrico. No acompanhamento terapêutico, vale atenção especial aos primeiros dias e primeiras 1 a 2 semanas, quando podem surgir mudanças mais nítidas de sono, energia, irritabilidade, ansiedade ou humor; em usos mais prolongados, também podem ganhar peso a oscilação emocional, alterações corporais percebidas e desgaste com o tratamento. O ponto central na sessão é distinguir ativação relacionada ao uso, sofrimento pela condição clínica de base, impacto de dor ou limitação física e reações a eventos de vida ocorrendo em paralelo.

O paciente pode relatar

- **"Ativação e sono:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais acelerado: fala mais rápida, dificuldade de desacelerar, sensação de estar "ligado", redução do sono ou sono mais superficial. Isso pode se confundir com alívio por melhora clínica da doença de base, com ansiedade habitual ou com um período de maior exigência externa. A discriminação costuma depender de comparar com a linha de base, observar se a aceleração veio junto de menor necessidade de sono e mapear a proximidade temporal com o início ou retomada do medicamento.

Humor e irritabilidade: Podem aparecer labilidade, impaciência, reatividade aumentada, choro fácil ou irritação desproporcional a estímulos pequenos, às vezes em contraste com um motivo externo pouco convincente para a intensidade observada. Também é possível que o paciente descreva euforia, sensação de potência ou confiança incomum, o que pode ser lido apressadamente como melhora global. Vale considerar, ao mesmo tempo, dor, privação de sono, estresse com a doença e conflitos familiares, que também alteram o humor e podem coexistir com o uso.

Ansiedade e inquietação: Alguns pacientes chegam mais tensos, com inquietação corporal, sensação de urgência, dificuldade de permanecer em repouso ou aumento de ruminação. Na sessão, isso pode parecer uma intensificação do padrão ansioso prévio, mas às vezes o paciente diferencia bem uma ansiedade "na cabeça" de um estado mais corporal e abrupto. Observar se houve mudança recente no tratamento, se a inquietação acompanha piora do sono e se o conteúdo psíquico da ansiedade é proporcional aos acontecimentos ajuda a não atribuir tudo automaticamente ao quadro de base.

Imagem corporal: Quando o uso se prolonga, mudanças percebidas no corpo, no peso ou no rosto podem ganhar centralidade subjetiva e afetar autoestima, sexualidade e evitação social. O sofrimento pode aparecer menos como "efeito colateral" nomeado e mais como vergonha, retraimento, comparação social e sensação de perda de familiaridade com a própria imagem. Aqui é fácil confundir impacto corporal do tratamento com rebaixamento depressivo primário ou com conflitos prévios de autoimagem que o contexto atual reativa.

Carga do tratamento: Como a prednisona costuma entrar em contextos de doença clínica ativa, a sessão frequentemente é atravessada por fadiga de tratamento, medo de piora, frustração com limitações e sensação de vida organizada em torno de sintomas e consultas. Às vezes o paciente atribui todo mal-estar ao remédio; em outras, minimiza o peso da própria condição e da rotina médica. O trabalho clínico se beneficia ao separar o que parece mudança subjetiva após o início do uso do que decorre da doença, da dor, da interrupção da rotina e do impacto identitário de estar em tratamento."

O que observar em sessão

- **Ativação e sono:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais acelerado: fala mais rápida, dificuldade de desacelerar, sensação de estar “ligado”, redução do sono ou sono mais superficial. Isso pode se confundir com alívio por melhora clínica da doença de base, com ansiedade habitual ou com um período de maior exigência externa. A discriminação costuma depender de comparar com a linha de base, observar se a aceleração veio junto de menor necessidade de sono e mapear a proximidade temporal com o início ou retomada do medicamento.

Humor e irritabilidade: Podem aparecer labilidade, impaciência, reatividade aumentada, choro fácil ou irritação desproporcional a estímulos pequenos, às vezes em contraste com um motivo externo pouco convincente para a intensidade observada. Também é possível que o paciente descreva euforia, sensação de potência ou confiança incomum, o que pode ser lido apressadamente como melhora global. Vale considerar, ao mesmo tempo, dor, privação de sono, estresse com a doença e conflitos familiares, que também alteram o humor e podem coexistir com o uso.

Ansiedade e inquietação: Alguns pacientes chegam mais tensos, com inquietação corporal, sensação de urgência, dificuldade de permanecer em repouso ou aumento de ruminação. Na sessão, isso pode parecer uma intensificação do padrão ansioso prévio, mas às vezes o paciente diferencia bem uma ansiedade “na cabeça” de um estado mais corporal e abrupto. Observar se houve mudança recente no tratamento, se a inquietação acompanha piora do sono e se o conteúdo psíquico da ansiedade é proporcional aos acontecimentos ajuda a não atribuir tudo automaticamente ao quadro de base.

Imagem corporal: Quando o uso se prolonga, mudanças percebidas no corpo, no peso ou no rosto podem ganhar centralidade subjetiva e afetar autoestima, sexualidade e evitação social. O sofrimento pode aparecer menos como “efeito colateral” nomeado e mais como vergonha, retraimento, comparação social e sensação de perda de familiaridade com a própria imagem. Aqui é fácil confundir impacto corporal do tratamento com rebaixamento depressivo primário ou com conflitos prévios de autoimagem que o contexto atual reativa.

Carga do tratamento: Como a prednisona costuma entrar em contextos de doença clínica ativa, a sessão frequentemente é atravessada por fadiga de tratamento, medo de piora, frustração com limitações e sensação de vida organizada em torno de sintomas e consultas. Às vezes o paciente atribui todo mal-estar ao remédio; em outras, minimiza o peso da própria condição e da rotina médica. O trabalho clínico se beneficia ao separar o que parece mudança subjetiva após o início do uso do que decorre da doença, da dor, da interrupção da rotina e do impacto identitário de estar em tratamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Prednisona é um corticosteroide sistêmico usado em quadros inflamatórios, alérgicos e autoimunes, e às vezes aparece no consultório sem que o foco inicial do tratamento seja psiquiátrico. No acompanhamento terapêutico, vale atenção especial aos primeiros dias e primeiras 1 a 2 semanas, quando podem surgir mudanças mais nítidas de sono, energia, irritabilidade, ansiedade ou humor; em usos mais prolongados, também podem ganhar peso a oscilação emocional, alterações corporais percebidas e desgaste com o tratamento. O ponto central na sessão é distinguir ativação relacionada ao uso, sofrimento pela condição clínica de base, impacto de dor ou limitação física e reações a eventos de vida ocorrendo em paralelo.

Perguntas úteis

- "Essas mudanças de energia e sono começaram mais perto do início do remédio ou já vinham se desenhando antes, com os acontecimentos da sua vida? , Quando você se sente mais acelerado, isso parece uma ansiedade com pensamentos e preocupações reconhecíveis ou um estado mais corporal, como se estivesse ligado sem conseguir desacelerar? , Essa melhora de disposição vem com mais clareza e estabilidade para viver o dia ou junto com irritação, impulsividade e menos necessidade de dormir? , O incômodo com o corpo apareceu depois de mudanças percebidas no tratamento ou ele se parece mais com uma insatisfação antiga que ficou mais intensa agora? , Nos dias em que você dorme melhor, essa irritabilidade diminui de forma clara ou ela permanece quase no mesmo nível? , Quando seu humor oscila, isso acompanha piora dos sintomas físicos da doença, conflitos concretos do dia ou parece surgir sem um gatilho proporcional?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a dormir muito menos e chega à sessão com aceleração incomum
- irritabilidade ou expansividade fora da linha de base
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a mudança temporalmente e avaliar relevância clínica
- Quando a ansiedade ou inquietação corporal se intensifica logo após início ou retomada do uso e começa a comprometer vínculo
- rotina ou permanência em sessão
- pode valer comunicação para registro e manejo integrado do caso
- Quando alterações de humor levam a conflitos importantes
- impulsividade ou prejuízo funcional novo
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar efeito do tratamento
- evolução do quadro e impacto do contexto clínico
- Quando o sofrimento com mudanças corporais passa a sustentar evitação social
- retraimento acentuado ou risco de abandono silencioso do tratamento
- pode valer comunicação para que a equipe tenha essa informação
- Quando o paciente relata uso irregular

Amarelo: alinhar em breve

- interrupções por conta própria ou grande ambivalência em seguir o tratamento por causa do que sente
- pode valer alinhar com o médico assistente pela relevância clínica da adesão

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente apresenta ideação suicida nova ou claramente intensificada
- sobretudo se isso surge junto de agitação
- insônia importante ou piora abrupta do humor após início recente do uso.: Fazer avaliação de risco no mesmo atendimento e acionar no mesmo dia o médico assistente
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Surge um estado de aceleração marcante
- com fala muito pressionada
- grandiosidade
- irritabilidade intensa
- impulsividade e pouca ou nenhuma necessidade de sono em comparação com a linha de base.: Tratar como mudança aguda relevante e buscar contato médico no mesmo dia
- com acionamento de rede de apoio se houver risco comportamental

Frase clínica

Na terapia, o foco com prednisona é diferenciar ativação e oscilação de humor do impacto da doença de base, do sono ruim e dos eventos de vida.

011 RAMELTEONA

Substância: Ramelteona.

Nomes Comerciais: Ramelteona, Rahime, Rozerem

Uso comum

- Ramelteona é um hipnótico usado sobretudo para insônia com dificuldade para iniciar o sono. No consultório, tende a aparecer em pacientes com queixa de latência prolongada, rotina de sono desorganizada ou hiperalerta noturno, muitas vezes junto de ansiedade, depressão ou estresse crônico. Quando há benefício, ele costuma ser percebido nos primeiros dias a 1-2 semanas, mais no horário de adormecer do que na qualidade global do sono. O ponto central na sessão é distinguir melhora do início do sono de mudanças mais amplas no quadro emocional, além de observar sonolência residual, uso irregular e expectativas de efeito imediato que podem levar a abandono silencioso.

O paciente pode relatar

- **"Início do sono:** O ganho mais relevante costuma aparecer como menor tempo até pegar no sono, sem necessariamente mudar despertares noturnos, sono fragmentado ou cansaço diurno. Na sessão, isso pode surgir como alívio localizado, enquanto o paciente ainda se percebe exausto, irritadiço ou pouco funcional durante o dia. Vale não confundir essa melhora parcial com remissão de ansiedade ou depressão, nem tomar a persistência de fadiga como prova de falha do medicamento quando a higiene do sono, o ritmo de vida ou outras condições seguem pesando.

Sonolência residual: Alguns pacientes chegam mais lentificados, bocejando, com atenção oscilante ou sensação de “ressaca” ao acordar, especialmente quando o horário de dormir é irregular ou o tempo disponível para sono é curto. Esse quadro pode se parecer com piora depressiva, privação de sono acumulada ou efeito de outras medicações sedativas em uso concomitante. A observação clínica ganha precisão quando se acompanha se a lentificação é mais matinal, se melhora ao longo do dia e se coincide com mudanças recentes na rotina noturna.

Adesão e rotina: Como o alvo é o adormecer, o uso irregular tende a aparecer quando o paciente alterna noites em que “tenta dormir cedo” com outras em que se deita muito tarde, usa telas até o limite ou desiste do tratamento por não notar efeito global imediato. Na sessão, isso pode surgir como narrativa de “não funcionou” sem uma linha de base minimamente estável para comparação. Também convém considerar que eventos de vida, viagens, trabalho em turnos e fins de semana desorganizados podem produzir oscilação do sono que parece falha do medicamento, mas reflete sobretudo irregularidade do contexto.

Ansiedade noturna: Parte dos pacientes descreve redução da luta para iniciar o sono, enquanto outros mantêm ruminação, antecipação ansiosa e vigilância corporal mesmo quando o horário de dormir melhora um pouco. O terapeuta pode notar que a queixa central continua sendo a mente acelerada, e não apenas a incapacidade de adormecer. Essa distinção ajuda a não atribuir toda persistência da insônia ao medicamento quando o núcleo do problema segue sendo ansiedade de desempenho para dormir, estresse agudo ou conflito emocional ativo.

Qualidade do dia seguinte: Mesmo com início do sono mais fácil, o paciente pode não relatar melhora proporcional em humor, energia, concentração ou tolerância afetiva no dia seguinte. Em sessão, isso pede cautela para diferenciar benefício circunscrito no sono de expectativa de transformação global do funcionamento. Quando a noite melhora mas o dia permanece muito comprometido, vale considerar manutenção do quadro de base, sono ainda insuficiente por outros motivos ou leitura excessivamente binária de sucesso versus fracasso."

O que observar em sessão

- **Início do sono:** O ganho mais relevante costuma aparecer como menor tempo até pegar no sono, sem necessariamente mudar despertares noturnos, sono fragmentado ou cansaço diurno. Na sessão, isso pode surgir como alívio localizado, enquanto o paciente ainda se percebe exausto, irritadiço ou pouco funcional durante o dia. Vale não confundir essa melhora parcial com remissão de ansiedade ou depressão, nem tomar a persistência de fadiga como prova de falha do medicamento quando a higiene do sono, o ritmo de vida ou outras condições seguem pesando.

Sonolência residual: Alguns pacientes chegam mais lentificados, bocejando, com atenção oscilante ou sensação de “ressaca” ao acordar, especialmente quando o horário de dormir é irregular ou o tempo disponível para sono é curto. Esse quadro pode se parecer com piora depressiva, privação de sono acumulada ou efeito de outras medicações sedativas em uso concomitante. A observação clínica ganha precisão quando se acompanha se a lentificação é mais matinal, se melhora ao longo do dia e se coincide com mudanças recentes na rotina noturna.

Adesão e rotina: Como o alvo é o adormecer, o uso irregular tende a aparecer quando o paciente alterna noites em que “tenta dormir cedo” com outras em que se deita muito tarde, usa telas até o limite ou desiste do tratamento por não notar efeito global imediato. Na sessão, isso pode surgir como narrativa de “não funcionou” sem uma linha de base minimamente estável para comparação. Também convém considerar que eventos de vida, viagens, trabalho em turnos e fins de semana desorganizados podem produzir oscilação do sono que parece falha do medicamento, mas reflete sobretudo irregularidade do contexto.

Ansiedade noturna: Parte dos pacientes descreve redução da luta para iniciar o sono, enquanto outros mantêm ruminação, antecipação ansiosa e vigilância corporal mesmo quando o horário de dormir melhora um pouco. O terapeuta pode notar que a queixa central continua sendo a mente acelerada, e não apenas a incapacidade de adormecer. Essa distinção ajuda a não atribuir toda persistência da insônia ao medicamento quando o núcleo do problema segue sendo ansiedade de desempenho para dormir, estresse agudo ou conflito emocional ativo.

Qualidade do dia seguinte: Mesmo com início do sono mais fácil, o paciente pode não relatar melhora proporcional em humor, energia, concentração ou tolerância afetiva no dia seguinte. Em sessão, isso pede cautela para diferenciar benefício circunscrito no sono de expectativa de transformação global do funcionamento. Quando a noite melhora mas o dia permanece muito comprometido, vale considerar manutenção do quadro de base, sono ainda insuficiente por outros motivos ou leitura excessivamente binária de sucesso versus fracasso.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Ramelteona é um hipnótico usado sobretudo para insônia com dificuldade para iniciar o sono. No consultório, tende a aparecer em pacientes com queixa de latência prolongada, rotina de sono desorganizada ou hiperalerta noturno, muitas vezes junto de ansiedade, depressão ou estresse crônico. Quando há benefício, ele costuma ser percebido nos primeiros dias a 1-2 semanas, mais no horário de adormecer do que na qualidade global do sono. O ponto central na sessão é distinguir melhora do início do sono de mudanças mais amplas no quadro emocional, além de observar sonolência residual, uso irregular e expectativas de efeito imediato que podem levar a abandono silencioso.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que o remédio não ajudou, o problema principal continua sendo pegar no sono, acordar no meio da noite ou acordar já cansado? , Nos dias em que você percebe mais lentidão ou sonolência, isso aparece logo ao acordar e vai passando, ou fica parecido o dia inteiro? , Quando a noite é ruim, isso costuma vir mais de pensamentos acelerados e preocupação, ou de você simplesmente não conseguir adormecer mesmo estando com sono? , Nas noites em que você usa, seu horário de deitar e a rotina antes de dormir ficam parecidos com os de outras noites, ou variam bastante? , Quando houve alguma melhora, ela apareceu só para iniciar o sono ou você também notou mudança clara no humor, na energia e na concentração durante o dia?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente mantém dificuldade importante para iniciar o sono após 1-2 semanas de uso aparentemente regular
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar se a resposta esperada não está ocorrendo
- Quando a sessão mostra sonolência residual frequente
- identificação marcante pela manhã ou prejuízo funcional no dia seguinte
- pode valer comunicar o médico para qualificar tolerabilidade e impacto clínico
- Quando o paciente relata uso muito irregular
- abandono silencioso ou expectativas frustradas que estão levando a desistência
- pode valer informar o médico porque a adesão fica difícil de estimar apenas pelo resultado percebido
- Quando a insônia piora apesar de alguma melhora inicial
- sobretudo em contexto de ansiedade noturna intensa
- eventos de vida ou outras medicações sedativas
- pode valer contato para ajudar a discriminar falha do tratamento de fatores concorrentes
- Quando surgem mudanças comportamentais incomuns durante a noite
- confusão ao despertar ou relato de comportamentos pouco lembrados
- pode valer comunicação ao médico para avaliação de segurança

Vermelho: tratar como urgência

- Confusão importante
- rebaixamento do nível de alerta ou comportamento noturno incomum com risco de queda
- acidente ou exposição a perigo.: Interromper o foco habitual da sessão
- acionar apoio imediato e contato médico no mesmo dia; considerar emergência se houver risco atual
- Ideação suicida emergente ou agravada em contexto de insônia intensa
- desesperança e exaustão importante.: Fazer manejo de risco na própria sessão
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia; recorrer à emergência quando necessário

Frase clínica

O foco é separar melhora do adormecer de persistência da insônia, ansiedade noturna e sonolência residual no dia seguinte.

012 EFAVIRENZ

Substância: Efavirenz.

Nomes Comerciais: Evir, Efavirenz

Uso comum

- Efavirenz é um antirretroviral usado no tratamento do HIV e costuma aparecer no consultório mais pelo impacto subjetivo do tratamento contínuo do que por manejo medicamentoso em si. Nas primeiras dias a poucas semanas, alguns pacientes descrevem sonhos vívidos, sono fragmentado, sensação de estranheza psíquica, ansiedade ou oscilação do humor; em parte dos casos isso perde intensidade ao longo das primeiras 2 a 4 semanas, mas pode persistir. Na sessão, o ponto central é diferenciar um mal-estar temporalmente ligado ao início ou à tomada irregular do medicamento de sofrimento associado ao diagnóstico, estigma, medo de adoecer, uso de substâncias e sobrecarga do tratamento.

O paciente pode relatar

- **"Sono e sonhos:** Nas primeiras semanas, o paciente pode chegar mais cansado, descrevendo sonhos muito vívidos, despertares frequentes, sensação de sono pouco reparador ou receio de dormir. Em sessão, isso às vezes aparece como irritabilidade, menor tolerância à frustração, dificuldade de associação e oscilação entre cansaço e agitação. Vale não atribuir automaticamente ao medicamento: ansiedade ligada ao diagnóstico, uso de álcool ou outras substâncias, mudanças de rotina e sofrimento depressivo também podem produzir um padrão semelhante, e a relação temporal com o início do uso ou com tomadas irregulares ajuda a discriminar.

Estranheza psíquica: Alguns pacientes descrevem sensação de estar diferente de si, mais confusos, lentificados ou com uma qualidade incomum da experiência subjetiva, especialmente no começo do tratamento. No consultório, isso pode ser percebido como discurso menos fluido, dificuldade de simbolização ou um afastamento do próprio afeto que não coincide exatamente com embotamento depressivo habitual. A leitura pode se confundir com privação de sono, uso concomitante de outras medicações, consumo de substâncias ou impacto emocional do diagnóstico recente, por isso importa observar se houve mudança nítida de baseline após o início do tratamento.

Humor e ansiedade: Pode haver aumento de ansiedade, irritabilidade, labilidade emocional ou rebaixamento do humor, sobretudo no início ou em fases de adesão irregular. Em sessão, o terapeuta pode notar reatividade maior, menor capacidade de elaboração e tendência a interpretar sensações corporais ou psíquicas como sinal de piora global. Também aqui há sobreposição importante com eventos de vida, medo de estigma, conflitos relacionais e curso do próprio quadro psiquiátrico prévio; a discriminação depende de mapear temporalidade, intensidade e se o padrão oscila junto com o uso do medicamento.

Adesão e evitamento: Quando a experiência subjetiva com o tratamento é desagradável, alguns pacientes passam a omitir tomadas, atrasar horários ou evitar falar disso por vergonha, cansaço ou receio de desapontar a equipe. Na terapia, isso pode surgir indiretamente como racionalizações, minimização de sintomas, oscilação difícil de entender entre dias muito diferentes ou afastamento do tema saúde. O risco clínico não é apenas o desconforto em si, mas o abandono silencioso; ao mesmo tempo, faltas de adesão também podem refletir rotina caótica, uso de substâncias, depressão ou dificuldades práticas, e não apenas efeito percebido do medicamento.

Estigma e identidade: Em muitos casos, o que ocupa a sessão não é um efeito específico, mas o peso de viver em tratamento contínuo para HIV: segredo, medo de rejeição, mudanças na autoimagem e sensação de vulnerabilidade. O paciente pode parecer mais retraído, hipervigilante ou dividido entre normalizar tudo e colapsar diante de pequenos sinais corporais. Esse sofrimento pode ser confundido com piora medicamentosa quando, na verdade, está mais ligado ao momento do diagnóstico, à relação com parceiros e família ou a experiências prévias de discriminação; sustentar essa diferenciação protege o trabalho terapêutico de leituras simplistas."

O que observar em sessão

- **Sono e sonhos:** Nas primeiras semanas, o paciente pode chegar mais cansado, descrevendo sonhos muito vívidos, despertares frequentes, sensação de sono pouco reparador ou receio de dormir. Em sessão, isso às vezes aparece como irritabilidade, menor tolerância à frustração, dificuldade de associação e oscilação entre cansaço e agitação. Vale não atribuir automaticamente ao medicamento: ansiedade ligada ao diagnóstico, uso de álcool ou outras substâncias, mudanças de rotina e sofrimento depressivo também podem produzir um padrão semelhante, e a relação temporal com o início do uso ou com tomadas irregulares ajuda a discriminar.

Estranheza psíquica: Alguns pacientes descrevem sensação de estar diferente de si, mais confusos, lentificados ou com uma qualidade incomum da experiência subjetiva, especialmente no começo do tratamento. No consultório, isso pode ser percebido como discurso menos fluido, dificuldade de simbolização ou um afastamento do próprio afeto que não coincide exatamente com embotamento depressivo habitual. A leitura pode se confundir com privação de sono, uso concomitante de outras medicações, consumo de substâncias ou impacto emocional do diagnóstico recente, por isso importa observar se houve mudança nítida de baseline após o início do tratamento.

Humor e ansiedade: Pode haver aumento de ansiedade, irritabilidade, labilidade emocional ou rebaixamento do humor, sobretudo no início ou em fases de adesão irregular. Em sessão, o terapeuta pode notar reatividade maior, menor capacidade de elaboração e tendência a interpretar sensações corporais ou psíquicas como sinal de piora global. Também aqui há sobreposição importante com eventos de vida, medo de estigma, conflitos relacionais e curso do próprio quadro psiquiátrico prévio; a discriminação depende de mapear temporalidade, intensidade e se o padrão oscila junto com o uso do medicamento.

Adesão e evitamento: Quando a experiência subjetiva com o tratamento é desagradável, alguns pacientes passam a omitir tomadas, atrasar horários ou evitar falar disso por vergonha, cansaço ou receio de desapontar a equipe. Na terapia, isso pode surgir indiretamente como racionalizações, minimização de sintomas, oscilação difícil de entender entre dias muito diferentes ou afastamento do tema saúde. O risco clínico não é apenas o desconforto em si, mas o abandono silencioso; ao mesmo tempo, faltas de adesão também podem refletir rotina caótica, uso de substâncias, depressão ou dificuldades práticas, e não apenas efeito percebido do medicamento.

Estigma e identidade: Em muitos casos, o que ocupa a sessão não é um efeito específico, mas o peso de viver em tratamento contínuo para HIV: segredo, medo de rejeição, mudanças na autoimagem e sensação de vulnerabilidade. O paciente pode parecer mais retraído, hipervigilante ou dividido entre normalizar tudo e colapsar diante de pequenos sinais corporais. Esse sofrimento pode ser confundido com piora medicamentosa quando, na verdade, está mais ligado ao momento do diagnóstico, à relação com parceiros e família ou a experiências prévias de discriminação; sustentar essa diferenciação protege o trabalho terapêutico de leituras simplistas.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Efavirenz é um antirretroviral usado no tratamento do HIV e costuma aparecer no consultório mais pelo impacto subjetivo do tratamento contínuo do que por manejo medicamentoso em si. Nas primeiras dias a poucas semanas, alguns pacientes descrevem sonhos vívidos, sono fragmentado, sensação de estranheza psíquica, ansiedade ou oscilação do humor; em parte dos casos isso perde intensidade ao longo das primeiras 2 a 4 semanas, mas pode persistir. Na sessão, o ponto central é diferenciar um mal-estar temporalmente ligado ao início ou à tomada irregular do medicamento de sofrimento associado ao diagnóstico, estigma, medo de adoecer, uso de substâncias e sobrecarga do tratamento.

Perguntas úteis

- "Essas mudanças começaram logo depois do início do remédio ou você já reconhece esse mesmo padrão em outros momentos da sua vida? , Quando a noite é mais difícil, no dia seguinte você se sente principalmente sonolento e esgotado, ou mais acelerado e apreensivo? , Essa sensação de estar estranho por dentro vem junto com cansaço e sono ruim, ou aparece mesmo em dias em que você dormiu melhor? , Nos dias em que você se sente pior, houve alguma mudança na rotina de tomada, uso de álcool ou outras substâncias, ou aconteceu algo importante fora disso? , Quando o humor cai, isso parece vir como um peso afetivo ligado a pensamentos e acontecimentos, ou mais como uma mudança brusca no seu estado sem um motivo claro?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve sonhos intensos
- insônia ou sensação de estranheza psíquica que persistem além das primeiras semanas e começam a comprometer funcionamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o impacto clínico atual
- Quando aparecem oscilações importantes de humor
- ansiedade ou irritabilidade após início recente do tratamento
- sobretudo se o paciente tem antecedente psiquiátrico
- pode valer comunicar para avaliação conjunta da temporalidade e da gravidade
- Quando o paciente admite tomadas irregulares
- interrupções por conta própria ou evitamento persistente do tratamento por desconforto subjetivo
- pode valer alinhar com o médico assistente porque isso interfere diretamente no cuidado
- Quando surgem ideias de morte
- desesperança acentuada ou piora importante do humor em proximidade temporal com o uso
- pode valer contato com o médico para avaliação mais rápida
- Quando a sessão passa a ser dominada por confusão
- desorganização incomum ou alteração marcante do padrão mental habitual
- pode valer comunicar para esclarecer se há relação com tratamento

Amarelo: alinhar em breve

- sono
- substâncias ou outro quadro clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem ideias de morte
- autoagressão ou desesperança intensa
- especialmente se houve piora recente e mudança nítida do baseline.: Fazer avaliação de risco na própria sessão e acionar hoje psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente chega muito confuso
- desorganizado
- intensamente agitado ou com percepção da realidade claramente alterada em relação ao seu padrão habitual.: Interromper a leitura apenas psicoterápica do quadro e buscar avaliação médica no mesmo dia
- com apoio da rede e emergência se necessário

Frase clínica

Com efavirenz, o foco é separar sofrimento do tratamento contínuo e efeitos subjetivos iniciais de piora psiquiátrica ou adesão irregular.

013 NUSINERSENA

Substância: Nusinersena.

Nomes Comerciais: Spinraza

Uso comum

- Nusinersena é uma terapia altamente especializada usada no acompanhamento contínuo da atrofia muscular espinhal, quadro raro e de grande impacto funcional. No consultório de terapia, o foco costuma recair menos sobre efeitos subjetivos diretos do medicamento e mais sobre o que o tratamento prolongado mobiliza: expectativa de ganho funcional, frustração com mudanças lentas, reorganização da rotina em torno de aplicações e exames, e oscilação entre esperança e exaustão. Ao longo de meses, vale acompanhar como pequenas mudanças motoras, intercorrências clínicas e a carga do cuidado repercutem no humor, na autonomia percebida, na identidade e na sustentação do vínculo terapêutico.

O paciente pode relatar

- "Carga do tratamento:** O tratamento pode ocupar muito espaço psíquico e logístico, com deslocamentos, procedimentos, exames e necessidade de coordenação familiar ou de cuidadores. Em sessão, isso pode aparecer como cansaço acumulado, irritabilidade, sensação de vida suspensa ou dificuldade de manter continuidade em temas que não sejam a doença. A leitura pode se confundir com desânimo depressivo, sobrecarga do cuidador, piora clínica de base ou simples exaustão por rotina médica intensa, por isso vale situar o sofrimento no contexto concreto das últimas semanas.

Funcionalidade e identidade: Pequenas mudanças de função, para melhor ou para pior, tendem a ter peso subjetivo desproporcional, porque tocam autonomia, dependência e projetos de vida. O paciente pode oscilar entre orgulho por ganhos discretos e vergonha por limitações persistentes, e o terapeuta pode notar maior sensibilidade a comparações, luto por perdas e reatividade a comentários do entorno. Nem toda oscilação emocional indica efeito do tratamento; muitas vezes ela acompanha marcos funcionais, intercorrências clínicas, mudanças no cuidado diário ou expectativas muito altas depositadas no acompanhamento.

Vínculo com a equipe: Em condições raras e tratamentos especializados, a relação com a equipe assistente costuma ganhar centralidade e pode aparecer carregada de idealização, gratidão, desconfiança ou sensação de abandono. Na sessão, isso pode surgir como dificuldade de formular dúvidas, medo de parecer ingrato, ou leitura de qualquer contratempo como sinal de falha do tratamento. Também aqui convém diferenciar sofrimento ligado à comunicação com a equipe, à incerteza do prognóstico e à dependência de um sistema de cuidado complexo, em vez de atribuir rapidamente a mudança ao medicamento em si."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode ocupar muito espaço psíquico e logístico, com deslocamentos, procedimentos, exames e necessidade de coordenação familiar ou de cuidadores. Em sessão, isso pode aparecer como cansaço acumulado, irritabilidade, sensação de vida suspensa ou dificuldade de manter continuidade em temas que não sejam a doença. A leitura pode se confundir com desânimo depressivo, sobrecarga do cuidador, piora clínica de base ou simples exaustão por rotina médica intensa, por isso vale situar o sofrimento no contexto concreto das últimas semanas.

Funcionalidade e identidade: Pequenas mudanças de função, para melhor ou para pior, tendem a ter peso subjetivo desproporcional, porque tocam autonomia, dependência e projetos de vida. O paciente pode oscilar entre orgulho por ganhos discretos e vergonha por limitações persistentes, e o terapeuta pode notar maior sensibilidade a comparações, luto por perdas e reatividade a comentários do entorno. Nem toda oscilação emocional indica efeito do tratamento; muitas vezes ela acompanha marcos funcionais, intercorrências clínicas, mudanças no cuidado diário ou expectativas muito altas depositadas no acompanhamento.

Vínculo com a equipe: Em condições raras e tratamentos especializados, a relação com a equipe assistente costuma ganhar centralidade e pode aparecer carregada de idealização, gratidão, desconfiança ou sensação de abandono. Na sessão, isso pode surgir como dificuldade de formular dúvidas, medo de parecer ingrato, ou leitura de qualquer contratempo como sinal de falha do tratamento. Também aqui convém diferenciar sofrimento ligado à comunicação com a equipe, à incerteza do prognóstico e à dependência de um sistema de cuidado complexo, em vez de atribuir rapidamente a mudança ao medicamento em si.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Nusinersena é uma terapia altamente especializada usada no acompanhamento contínuo da atrofia muscular espinhal, quadro raro e de grande impacto funcional. No consultório de terapia, o foco costuma recair menos sobre efeitos subjetivos diretos do medicamento e mais sobre o que o tratamento prolongado mobiliza: expectativa de ganho funcional, frustração com mudanças lentas, reorganização da rotina em torno de aplicações e exames, e oscilação entre esperança e exaustão. Ao longo de meses, vale acompanhar como pequenas mudanças motoras, intercorrências clínicas e a carga do cuidado repercutem no humor, na autonomia percebida, na identidade e na sustentação do vínculo terapêutico.

Perguntas úteis

- "Quando você sai de consultas, exames ou aplicações, o que fica mais forte: cansaço físico, alívio, medo do futuro ou frustração por esperar mudanças maiores? , Nas últimas semanas, o que mais pesou no seu humor: alguma mudança concreta no seu corpo e na sua rotina, ou a expectativa sobre o que o tratamento deveria estar trazendo? , Quando você se sente pior, isso costuma vir depois de intercorrências médicas e exigências do tratamento, ou aparece mesmo em períodos mais estáveis da rotina? , Essas mudanças que você percebe em si têm alterado mais a sua autonomia no dia a dia, a forma como você se vê, ou a maneira como os outros passaram a olhar para você? , Quando surge vontade de evitar consultas, exames ou conversas sobre o tratamento, isso parece vir mais de exaustão, medo de se frustrar, sensação de inutilidade ou dificuldade prática de manter a rotina?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a evitar repetidamente consultas
- exames ou etapas do acompanhamento por exaustão
- desesperança ou sensação de inutilidade
- pode valer alinhar com a equipe assistente para situar risco de ruptura do cuidado
- Quando aparecem mudanças emocionais importantes após intercorrências clínicas ou procedimentos
- com impacto claro na adesão e na funcionalidade
- pode valer comunicação com o médico assistente para contextualizar o momento do tratamento
- Quando a sessão mostra sofrimento intenso ligado a perda funcional
- aumento de dependência ou sobrecarga familiar
- pode ser útil alinhar com a equipe para integrar melhor o cuidado e a sustentação do paciente
- Quando o paciente relata piora clínica relevante sem conseguir discriminar se houve mudança funcional real ou aumento da ansiedade e da vigilância corporal
- pode valer contato com o médico para compartilhar observações do funcionamento recente

Vermelho: tratar como urgência

- Surge fala de morte
- desistência de viver ou autoagressão em contexto de frustração intensa
- piora funcional ou sensação de ser um peso para os outros.: Fazer avaliação imediata de risco
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- recorrendo à emergência quando necessário
- Durante a sessão
- o paciente apresenta piora física aguda evidente

Vermelho: tratar como urgência

- grande dificuldade para falar ou respirar
- ou mal-estar importante que foge do seu padrão habitual.: Interromper o enquadre terapêutico
- buscar avaliação médica imediata e acionar acompanhante
- equipe ou emergência conforme o contexto

Frase clínica

Com nusinersena, o centro da escuta costuma ser a carga do tratamento e o impacto de pequenas mudanças funcionais sobre identidade, esperança e adesão.

014 ONASEMNOGENO ABEPARVOVEQUE

Substância: Onasemnogeno Abeparvoveque.

Nomes Comerciais: Zolgensma

Uso comum

- Onasemnogeno abeparvoveque é uma terapia gênica usada na atrofia muscular espinhal, situação pouco frequente no consultório de psicoterapia e geralmente inserida em acompanhamento médico intensivo. Para o terapeuta, o foco costuma recair menos sobre efeitos específicos do produto e mais sobre o que o tratamento concentra nas semanas e meses ao redor da infusão: expectativa familiar elevada, medo de piora, sobrecarga logística, vigilância clínica intensa e reorganização da identidade em torno da doença. Na sessão, vale acompanhar como o paciente e a família significam ganhos, frustrações e incertezas, sem atribuir mudanças emocionais ou comportamentais diretamente ao medicamento.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** O tratamento pode ocupar grande espaço psíquico e prático, com deslocamentos, exames, monitoramento frequente e conversas recorrentes sobre prognóstico. Em sessão, isso pode aparecer como agenda tomada pelo tema médico, fadiga do cuidador, irritabilidade, dificuldade de manter continuidade terapêutica ou sensação de que a vida ficou suspensa. Esse quadro pode se confundir com agravamento emocional primário, mas muitas vezes acompanha a intensidade do cuidado exigido pela condição de base e pelo período de acompanhamento mais próximo após a intervenção.

Identidade e futuro: Mudanças no tratamento tendem a reativar fantasias de cura, medo de perda de função, comparação com outras crianças ou famílias e revisão brusca de expectativas sobre desenvolvimento e autonomia. O terapeuta pode notar oscilação entre esperança intensa e desalento, além de dificuldade de elaborar um futuro que não seja inteiramente definido pela doença. Nem toda oscilação indica efeito do tratamento; eventos clínicos, marcos do desenvolvimento e a forma como a equipe comunica perspectivas também pesam muito na experiência subjetiva.

Vínculo com a equipe: Em condições raras e de alta complexidade, a relação com a equipe assistente costuma ganhar centralidade e pode influenciar fortemente a regulação emocional da família. Na sessão, podem surgir idealização, desconfiança, exaustão com orientações sucessivas ou sensação de não conseguir sustentar dúvidas diante dos profissionais. Isso pode ser confundido com resistência inespecífica ou baixa adesão, quando às vezes reflete assimetria de informação, medo de errar no cuidado e histórico de frustrações acumuladas com o sistema de saúde."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode ocupar grande espaço psíquico e prático, com deslocamentos, exames, monitoramento frequente e conversas recorrentes sobre prognóstico. Em sessão, isso pode aparecer como agenda tomada pelo tema médico, fadiga do cuidador, irritabilidade, dificuldade de manter continuidade terapêutica ou sensação de que a vida ficou suspensa. Esse quadro pode se confundir com agravamento emocional primário, mas muitas vezes acompanha a intensidade do cuidado exigido pela condição de base e pelo período de acompanhamento mais próximo após a intervenção.

Identidade e futuro: Mudanças no tratamento tendem a reativar fantasias de cura, medo de perda de função, comparação com outras crianças ou famílias e revisão brusca de expectativas sobre desenvolvimento e autonomia. O terapeuta pode notar oscilação entre esperança intensa e desalento, além de dificuldade de elaborar um futuro que não seja inteiramente definido pela doença. Nem toda oscilação indica efeito do tratamento; eventos clínicos, marcos do desenvolvimento e a forma como a equipe comunica perspectivas também pesam muito na experiência subjetiva.

Vínculo com a equipe: Em condições raras e de alta complexidade, a relação com a equipe assistente costuma ganhar centralidade e pode influenciar fortemente a regulação emocional da família. Na sessão, podem surgir idealização, desconfiança, exaustão com orientações sucessivas ou sensação de não conseguir sustentar dúvidas diante dos profissionais. Isso pode ser confundido com resistência inespecífica ou baixa adesão, quando às vezes reflete assimetria de informação, medo de errar no cuidado e histórico de frustrações acumuladas com o sistema de saúde.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Onasemnogeno abeparvoveque é uma terapia gênica usada na atrofia muscular espinhal, situação pouco frequente no consultório de psicoterapia e geralmente inserida em acompanhamento médico intensivo. Para o terapeuta, o foco costuma recair menos sobre efeitos específicos do produto e mais sobre o que o tratamento concentra nas semanas e meses ao redor da infusão: expectativa familiar elevada, medo de piora, sobrecarga logística, vigilância clínica intensa e reorganização da identidade em torno da doença. Na sessão, vale acompanhar como o paciente e a família significam ganhos, frustrações e incertezas, sem atribuir mudanças emocionais ou comportamentais diretamente ao medicamento.

Perguntas úteis

- "Quando você sai de uma consulta ou exame, o que muda no seu humor nas horas e dias seguintes: aparece alívio, mais medo, ou sensação de ficar em alerta o tempo todo? , O que tem pesado mais nesta fase: a condição em si, a rotina de acompanhamento, ou a expectativa de que o tratamento precise mostrar resultado logo? , Quando você se sente mais abatido, isso costuma vir depois de alguma notícia médica, de comparações com outras crianças/famílias, ou aparece mesmo em dias sem novidades? , Nas semanas recentes, a terapia tem ficado mais difícil por cansaço e logística, ou porque falar do tema médico passou a parecer insuportável emocionalmente? , Quando surge esperança, ela vem acompanhada de maior capacidade de planejar o cotidiano, ou de uma pressão para que tudo melhore rapidamente?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando a família passa a faltar monitoramentos
- exames ou retornos por exaustão
- confusão ou evitação
- pode valer alinhar com a equipe assistente para situar o impacto disso no cuidado global
- Quando aparecem mudanças emocionais importantes logo após notícias clínicas
- com grande dificuldade de regulação e prejuízo claro da rotina
- pode valer comunicar o médico assistente para integrar leitura clínica e contexto do tratamento
- Quando o paciente ou cuidadores demonstram compreensão muito discrepante do que esperavam do tratamento
- com frustração intensa ou sensação de abandono
- pode valer alinhar com a equipe para reduzir ruído assistencial
- Quando a sobrecarga do cuidado compromete de modo relevante sono
- alimentação
- presença em sessão ou capacidade mínima de organização familiar
- pode valer contato com o médico assistente para contextualizar o funcionamento atual

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão aparecem ideias de morte
- desesperança extrema ou fala de que a família ou o paciente não vê mais sentido em seguir
- especialmente com menção a intenção ou plano.: Fazer manejo imediato de risco
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- recorrendo à emergência quando necessário
- O cuidador se mostra francamente desorganizado
- sem condições mínimas de sustentar decisões básicas de cuidado ou segurança do paciente naquele momento.: Priorizar contenção e avaliação de segurança

Vermelho: tratar como urgência

- mobilizar rede de apoio imediata e acionar a equipe assistente no mesmo dia

Frase clínica

Nesta ficha, o centro não é o produto, mas o impacto subjetivo e familiar de um tratamento intensivo para condição neuromuscular grave.

015 CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA

Substância: Cloridrato de Dexmedetomidina.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Dexmedetomidina, Bdexbraun, Dex, Dex Bolsa, Extodin, Simbilex, Precedex, Slipdex

Uso comum

- A dexmedetomidina é um sedativo de uso predominantemente hospitalar, mais ligada a UTI, procedimentos e contextos perioperatórios do que ao manejo ambulatorial contínuo. No consultório de terapia, quando aparece, o foco raramente é o fármaco em si, mas o paciente após internação, sedação recente ou tratamento intensivo. Nas horas a poucos dias após esse contexto, podem persistir lentificação, sonolência, fragmentação da memória do período e oscilação entre alívio por ter saído de uma situação crítica e estranhamento com o próprio funcionamento. O ponto central de observação é diferenciar rescaldo de internação e sedação de sofrimento psíquico emergente, delirium residual, trauma médico e impacto da doença de base.

O paciente pode relatar

- **"Pós-internação:** Muitas vezes o que chega à sessão é um paciente ainda organizando a experiência de internação, procedimento ou permanência em UTI. Pode haver fala mais lenta, cansaço, lacunas de memória e dificuldade de narrar a sequência dos acontecimentos, o que pode ser confundido com retraimento depressivo, resistência ou baixa implicação no processo. Vale situar temporalmente quando ocorreu a internação e comparar com a baseline prévia, porque a condição clínica aguda, outras medicações recebidas no hospital e privação de sono costumam pesar mais do que um efeito isolado da dexmedetomidina.

Cognição e memória: Alguns pacientes descrevem lembranças fragmentadas, sensação de confusão sobre o que aconteceu ou dificuldade de sustentar atenção por muito tempo na sessão. Isso pode se parecer com dissociação, ansiedade intensa ou piora cognitiva do quadro de base, mas também pode refletir recuperação ainda incompleta após sedação, doença aguda ou ambiente hospitalar desorganizador. O terapeuta ganha mais precisão ao observar se a desorientação está diminuindo ao longo de dias, se é flutuante e se se restringe ao período da internação ou já vinha antes.

Sono e vigília: Depois da alta, o padrão de sono pode ficar desregulado: sonolência diurna, cochilos involuntários, sono fragmentado à noite ou sensação de não recuperar energia. Na sessão, isso pode aparecer como lentificação, bocejos, dificuldade de associação e menor acesso afetivo, o que pode ser lido apressadamente como depressão, desengajamento ou efeito de outras medicações de uso crônico. A discriminação melhora quando se observa a relação com o horário da sessão, a proximidade da alta, dor, desconforto físico e mudanças bruscas na rotina doméstica.

Trauma médico: Em parte dos casos, o mais saliente não é a sedação, mas a experiência subjetiva de vulnerabilidade extrema, perda de controle corporal e medo de morrer. O paciente pode alternar alívio por estar vivo com hipervigilância, pesadelos, evitação de temas médicos ou necessidade repetitiva de reconstruir o que ocorreu, e isso pode ser confundido com ansiedade prévia ou dramatização. Vale notar se o afeto se intensifica ao falar de aparelhos, equipe, contenção, intubação ou lapsos de memória, porque esses marcadores ajudam a distinguir sofrimento traumático do simples cansaço pós-hospitalar."

O que observar em sessão

- **Pós-internação:** Muitas vezes o que chega à sessão é um paciente ainda organizando a experiência de internação, procedimento ou permanência em UTI. Pode haver fala mais lenta, cansaço, lacunas de memória e dificuldade de narrar a sequência dos acontecimentos, o que pode ser confundido com retraimento depressivo, resistência ou baixa implicação no processo. Vale situar temporalmente quando ocorreu a internação e comparar com a baseline prévia, porque a condição clínica aguda, outras medicações recebidas no hospital e privação de sono costumam pesar mais do que um efeito isolado da dexmedetomidina.

Cognição e memória: Alguns pacientes descrevem lembranças fragmentadas, sensação de confusão sobre o que aconteceu ou dificuldade de sustentar atenção por muito tempo na sessão. Isso pode se parecer com dissociação, ansiedade intensa ou piora cognitiva do quadro de base, mas também pode refletir recuperação ainda incompleta após sedação, doença aguda ou ambiente hospitalar desorganizador. O terapeuta ganha mais precisão ao observar se a desorientação está diminuindo ao longo de dias, se é flutuante e se se restringe ao período da internação ou já vinha antes.

Sono e vigília: Depois da alta, o padrão de sono pode ficar desregulado: sonolência diurna, cochilos involuntários, sono fragmentado à noite ou sensação de não recuperar energia. Na sessão, isso pode aparecer como lentificação, bocejos, dificuldade de associação e menor acesso afetivo, o que pode ser lido apressadamente como depressão, desengajamento ou efeito de outras medicações de uso crônico. A discriminação melhora quando se observa a relação com o horário da sessão, a proximidade da alta, dor, desconforto físico e mudanças bruscas na rotina doméstica.

Trauma médico: Em parte dos casos, o mais saliente não é a sedação, mas a experiência subjetiva de vulnerabilidade extrema, perda de controle corporal e medo de morrer. O paciente pode alternar alívio por estar vivo com hipervigilância, pesadelos, evitação de temas médicos ou necessidade repetitiva de reconstruir o que ocorreu, e isso pode ser confundido com ansiedade prévia ou dramatização. Vale notar se o afeto se intensifica ao falar de aparelhos, equipe, contenção, intubação ou lapsos de memória, porque esses marcadores ajudam a distinguir sofrimento traumático do simples cansaço pós-hospitalar.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A dexmedetomidina é um sedativo de uso predominantemente hospitalar, mais ligada a UTI, procedimentos e contextos perioperatórios do que ao manejo ambulatorial contínuo. No consultório de terapia, quando aparece, o foco raramente é o fármaco em si, mas o paciente após internação, sedação recente ou tratamento intensivo. Nas horas a poucos dias após esse contexto, podem persistir lentificação, sonolência, fragmentação da memória do período e oscilação entre alívio por ter saído de uma situação crítica e estranhamento com o próprio funcionamento. O ponto central de observação é diferenciar rescaldo de internação e sedação de sofrimento psíquico emergente, delirium residual, trauma médico e impacto da doença de base.

Perguntas úteis

- "Quando você tenta contar o que aconteceu na internação, a dificuldade é mais de lembrar trechos específicos ou de conseguir se concentrar em qualquer assunto da sessão? , Essa lentidão que aparece aqui se parece com sono e cansaço do corpo, ou com desânimo e perda de interesse que você reconhece de outros momentos da sua vida? , As lacunas de memória ficam mais ligadas ao período do hospital e do procedimento, ou você percebe confusão semelhante também em situações atuais do dia a dia? , Quando o assunto volta para a internação, o que aparece mais forte: medo, imagens soltas, sensação corporal de alerta ou apenas cansaço por lembrar de algo difícil? , Desde a alta, você sente que está melhorando aos poucos a cada dia, ou houve momentos de piora, confusão ou sonolência que parecem ir e voltar sem um padrão claro?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente permanece vários dias após a alta com confusão
- sonolência importante ou dificuldade de sustentar atenção na sessão
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se a recuperação esperada está ocorrendo como previsto
- Quando surgem lacunas extensas de memória
- desorganização marcante do pensamento ou flutuação importante do nível de alerta
- pode valer comunicação médica para diferenciar rescaldo pós-internação de complicações clínicas em curso
- Quando o paciente relata que recebeu alta recente
- mas segue muito limitado para alimentação
- hidratação
- autocuidado ou mobilização por rebaixamento e cansaço
- pode valer contato com a equipe assistente pela repercussão funcional
- Quando aparecem medo intenso
- pesadelos e evitação ligados à experiência hospitalar
- junto de confusão sobre o que de fato ocorreu
- pode valer alinhar com o médico para integrar a leitura do pós-internação e do sofrimento psíquico emergente

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente parece muito sonolento
- difícil de despertar
- confuso a ponto de não sustentar contato básico ou piora rapidamente durante o atendimento.: Interrompa a exploração psicoterápica e acione avaliação médica no mesmo dia; se houver rebaixamento importante

Vermelho: tratar como urgência

- considere emergência e rede de apoio imediata
- Há desorientação importante
- fala muito desconexa
- agitação súbita ou alternância rápida entre sonolência e inquietação após internação recente.:
Trate como necessidade de avaliação clínica hoje
- acionando médico assistente
- acompanhante ou serviço de urgência conforme o contexto

Frase clínica

Nesta ficha, o foco é menos a dexmedetomidina e mais o paciente após sedação e internação: vigília, memória, trauma médico e recuperação funcional.

016 CLORIDRATO DE ESCETAMINA

Substância: Cloridrato de Escetamina.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Escetamina, Ketamin, Ketah, Ketah Lc, Spravato

Uso comum

- O cloridrato de escetamina pode aparecer no consultório sobretudo em pacientes com depressão de difícil manejo, em geral como parte de um tratamento já mais complexo e acompanhado de perto. Para o terapeuta, a leitura clínica costuma se organizar em duas janelas: as horas após a administração, quando podem surgir alteração perceptiva, sensação de desligamento, sonolência, náusea ou oscilação de contato; e as primeiras semanas, quando se observa se há mudança em desesperança, ideação suicida, energia e capacidade de engajamento. O ponto central na sessão é diferenciar melhora real de um alívio breve ou de uma experiência subjetiva intensa que ainda não se traduziu em funcionamento mais estável.

O paciente pode relatar

- **"Estado pós-sessão:** Quando a sessão de terapia ocorre no mesmo dia ou no dia seguinte à administração, o paciente pode chegar mais lentificado, sonolento, com fala menos encadeada ou descrevendo sensação de estranhamento, distanciamento de si ou do ambiente. Isso pode alterar acesso afetivo e capacidade de elaboração sem significar piora do quadro de base. Vale situar temporalmente esses achados, porque uma sessão feita fora dessa janela pode mostrar um funcionamento bem diferente, e a leitura se confunde facilmente com depressão grave, evasividade defensiva ou uso de outras substâncias.

Alívio versus mudança: Em parte dos casos surge um alívio relativamente rápido de angústia, desesperança ou pressão suicida, mas nem sempre acompanhado de melhora proporcional em rotina, iniciativa ou vínculo com a vida. Na sessão, isso pode aparecer como discurso menos sombrio, porém ainda com baixa sustentação prática entre encontros. A distinção importa porque eventos de vida favoráveis, expectativa alta com o tratamento ou flutuação espontânea do episódio depressivo também podem produzir uma melhora inicial que depois não se mantém.

Dissociação e contato: Alguns pacientes descrevem experiências incomuns durante ou após a administração, como sensação de estar fora do corpo, tempo alterado, imagens vívidas ou dificuldade de nomear o que sentiram. No consultório, isso pode aparecer como narrativa fragmentada, perplexidade ou tentativa de dar sentido psicológico imediato a uma vivência ainda pouco elaborada. Convém não tomar automaticamente esse material como conteúdo simbólico do processo terapêutico nem como agravamento psicótico, sobretudo se o fenômeno estiver claramente ligado à janela próxima da administração.

Ideação suicida: Uma mudança em ideação suicida pode ocorrer antes de uma melhora mais ampla do humor, o que exige acompanhamento fino da diferença entre redução momentânea da urgência e recuperação mais consistente de perspectiva. Às vezes o paciente relata menos impulso, mas continua muito sem futuro, isolado ou com planejamento preservado; em outras, há ganho de energia antes de haver reorganização subjetiva. Também aqui adesão irregular, frustração com expectativas e intercorrências de vida podem embaralhar a leitura.

Engajamento no tratamento: Como costuma aparecer em contextos de maior gravidade e logística mais exigente, o tratamento pode mobilizar esperança intensa, ambivalência, cansaço e comparações com tentativas anteriores. Na sessão, isso se traduz em oscilação entre investimento renovado e desânimo, além de faltas, dificuldade de manter rotina ou sensação de que a vida ficou organizada em torno do tratamento. Nem toda oscilação indica efeito da substância; muitas vezes reflete a carga do próprio percurso depressivo, o impacto prático do cuidado e a exaustão acumulada."

O que observar em sessão

- **Estado pós-sessão:** Quando a sessão de terapia ocorre no mesmo dia ou no dia seguinte à administração, o paciente pode chegar mais lentificado, sonolento, com fala menos encadeada ou descrevendo sensação de estranhamento, distanciamento de si ou do ambiente. Isso pode alterar acesso afetivo e capacidade de elaboração sem significar piora do quadro de base. Vale situar temporalmente esses achados, porque uma sessão feita fora dessa janela pode mostrar um funcionamento bem diferente, e a leitura se confunde facilmente com depressão grave, evasividade defensiva ou uso de outras substâncias.

Alívio versus mudança: Em parte dos casos surge um alívio relativamente rápido de angústia, desesperança ou pressão suicida, mas nem sempre acompanhado de melhora proporcional em rotina, iniciativa ou vínculo com a vida. Na sessão, isso pode aparecer como discurso menos sombrio, porém ainda com baixa sustentação prática entre encontros. A distinção importa porque eventos de vida favoráveis, expectativa alta com o tratamento ou flutuação espontânea do episódio depressivo também podem produzir uma melhora inicial que depois não se mantém.

Dissociação e contato: Alguns pacientes descrevem experiências incomuns durante ou após a administração, como sensação de estar fora do corpo, tempo alterado, imagens vívidas ou dificuldade de nomear o que sentiram. No consultório, isso pode aparecer como narrativa fragmentada, perplexidade ou tentativa de dar sentido psicológico imediato a uma vivência ainda pouco elaborada. Convém não tomar automaticamente esse material como conteúdo simbólico do processo terapêutico nem como agravamento psicótico, sobretudo se o fenômeno estiver claramente ligado à janela próxima da administração.

Ideação suicida: Uma mudança em ideação suicida pode ocorrer antes de uma melhora mais ampla do humor, o que exige acompanhamento fino da diferença entre redução momentânea da urgência e recuperação mais consistente de perspectiva. Às vezes o paciente relata menos impulso, mas continua muito sem futuro, isolado ou com planejamento preservado; em outras, há ganho de energia antes de haver reorganização subjetiva. Também aqui adesão irregular, frustração com expectativas e intercorrências de vida podem embaralhar a leitura.

Engajamento no tratamento: Como costuma aparecer em contextos de maior gravidade e logística mais exigente, o tratamento pode mobilizar esperança intensa, ambivalência, cansaço e comparações com tentativas anteriores. Na sessão, isso se traduz em oscilação entre investimento renovado e desânimo, além de faltas, dificuldade de manter rotina ou sensação de que a vida ficou organizada em torno do tratamento. Nem toda oscilação indica efeito da substância; muitas vezes reflete a carga do próprio percurso depressivo, o impacto prático do cuidado e a exaustão acumulada.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O cloridrato de escetamina pode aparecer no consultório sobretudo em pacientes com depressão de difícil manejo, em geral como parte de um tratamento já mais complexo e acompanhado de perto. Para o terapeuta, a leitura clínica costuma se organizar em duas janelas: as horas após a administração, quando podem surgir alteração perceptiva, sensação de desligamento, sonolência, náusea ou oscilação de contato; e as primeiras semanas, quando se observa se há mudança em desesperança, ideação suicida, energia e capacidade de engajamento. O ponto central na sessão é diferenciar melhora real de um alívio breve ou de uma experiência subjetiva intensa que ainda não se traduziu em funcionamento mais estável.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que ficou melhor, isso apareceu mais como menos sofrimento por algumas horas ou como mudança que se manteve no seu jeito de viver os dias entre as sessões? , Nas vezes em que você se sentiu estranho ou desligado, isso aconteceu logo depois da administração e passou, ou tem aparecido também em outros dias e contextos? , A diminuição dos pensamentos de morte veio junto com mais vontade de se implicar na rotina e nos vínculos, ou foi mais uma trégua na urgência sem outras mudanças? , Quando você chega mais lento ou sonolento, isso parece concentrado perto do dia da aplicação ou combina com um cansaço depressivo que já vinha antes? , Essas experiências incomuns que você descreve ficaram restritas ao momento do tratamento ou começaram a influenciar também sua percepção de realidade fora dessa janela? , Quando a melhora não se mantém, você percebe mais relação com o intervalo entre aplicações, com acontecimentos da semana ou com dificuldade de sustentar o tratamento na prática?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve alívio inicial
- mas a ideação suicida retorna rapidamente ou permanece com planejamento e pouca ampliação de perspectiva
- pode valer alinhar com o médico assistente para reavaliar a sustentação clínica dessa resposta
- Quando a sessão mostra sonolência
- lentificação
- confusão ou estranhamento que ultrapassam claramente a janela esperada após a administração
- pode valer comunicar o médico para situar tolerabilidade e segurança
- Quando experiências de desligamento
- desrealização ou alteração perceptiva passam a aparecer fora do contexto próximo da administração
- pode valer contato com o médico para diferenciar fenômeno transitório de outra desorganização clínica
- Quando o paciente começa a faltar

Amarelo: alinhar em breve

- evita relatar como tem passado após as aplicações ou demonstra ambivalência importante que sugere adesão irregular
- pode valer alinhar com o médico para não perder informação clínica relevante
- Quando
 - após algumas semanas
 - não se observa mudança perceptível em desesperança
 - ideação suicida ou capacidade mínima de engajamento
 - pode valer comunicar o médico assistente para atualização do quadro funcional

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente apresenta ideação suicida atual com intenção
- planejamento ou sensação de que pode agir hoje
- mesmo referindo tratamento em curso.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar psiquiatra e rede de apoio e encaminhar para avaliação de urgência quando necessário
- O paciente chega muito confuso
- desorganizado
- intensamente agitado ou com alteração importante de contato com a realidade fora da janela próxima da administração.: Interromper o foco interpretativo
- priorizar avaliação de segurança e acionar o médico assistente no mesmo dia
- com emergência se houver risco clínico ou comportamental

Frase clínica

O foco clínico é distinguir alívio rápido e experiências intensas pós-administração de mudança sustentada em risco, funcionamento e vínculo com a vida.

017 CLORIDRATO DE MIDAZOLAM

Substância: Cloridrato de Midazolam.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Midazolam, Dormire

Uso comum

- Cloridrato de midazolam é um benzodiazepínico de ação curta, mais associado a sedação procedural, uso hospitalar e manejo pontual de agitação ou insônia em contextos específicos do que ao acompanhamento ambulatorial contínuo em psicoterapia. Quando aparece no consultório, costuma ser em torno de exames, internações, crises agudas ou uso episódico prescrito por outro contexto assistencial. O que mais importa ao terapeuta é situar a sessão em relação ao momento do uso: nas horas seguintes pode haver sonolência, lentificação, fala menos organizada e memória fragmentada; no dia seguinte ainda pode restar rebaixamento subjetivo. A observação central é diferenciar efeito sedativo transitório, sofrimento do contexto médico e uso irregular ou não combinado com outras substâncias.

O paciente pode relatar

- **"Sedação aguda:** Na sessão próxima ao uso, o paciente pode chegar mais sonolento, com atenção flutuante, fala arrastada, menor iniciativa associativa e redução do acesso reflexivo. Isso pode ser confundido com retraimento depressivo, exaustão por evento de vida ou efeito de privação de sono, especialmente se o encontro ocorre após procedimento, viagem, crise ou noite mal dormida. Vale observar se a lentificação apareceu de modo abrupto em relação à baseline e se melhora ao longo da própria sessão ou acompanha um contexto temporal muito próximo do uso.

Memória e continuidade: Uma pista clínica frequente é a lembrança fragmentada do que ocorreu antes, durante ou depois do uso, com dificuldade de reconstruir sequência temporal e detalhes de conversas, decisões ou eventos médicos. Em psicoterapia, isso pode parecer evitamento, dissociação ou baixa implicação, quando às vezes o paciente simplesmente não consegue recuperar o episódio com nitidez. A discriminação depende de comparar com o padrão habitual de memória autobiográfica e de verificar se a lacuna está circunscrita ao período próximo do uso ou se se estende para além dele.

Contexto médico: Midazolam costuma entrar na história em cenários de exame, internação, procedimento ou crise aguda, e o impacto subjetivo do contexto frequentemente pesa mais na sessão do que o fármaco em si. Ansiedade antecipatória, sensação de vulnerabilidade corporal, medo de perder controle e dependência temporária da equipe podem organizar o relato e a transferência. Se o terapeuta atribui tudo ao medicamento, pode perder elementos centrais do sofrimento ligado à condição clínica, ao ambiente hospitalar ou à experiência de ter precisado de contenção química.

Uso episódico e adesão: Como tende a aparecer em uso pontual, o dado decisivo é entender se houve administração supervisionada em contexto assistencial ou uso por conta própria fora desse enquadre. Oscilações entre sessões podem refletir não apenas o efeito sedativo breve, mas também repetição de uso em momentos de angústia, associação com álcool ou outras substâncias e dificuldade de relatar com precisão quando foi utilizado. O terapeuta ganha mais ao mapear padrão, contexto e função subjetiva do uso do que ao tentar inferir causalidade linear a partir de uma sessão isolada."

O que observar em sessão

- **Sedação aguda:** Na sessão próxima ao uso, o paciente pode chegar mais sonolento, com atenção flutuante, fala arrastada, menor iniciativa associativa e redução do acesso reflexivo. Isso pode ser confundido com retraimento depressivo, exaustão por evento de vida ou efeito de privação de sono, especialmente se o encontro ocorre após procedimento, viagem, crise ou noite mal dormida. Vale observar se a lentificação apareceu de modo abrupto em relação à baseline e se melhora ao longo da própria sessão ou acompanha um contexto temporal muito próximo do uso.

Memória e continuidade: Uma pista clínica frequente é a lembrança fragmentada do que ocorreu antes, durante ou depois do uso, com dificuldade de reconstruir sequência temporal e detalhes de conversas, decisões ou eventos médicos. Em psicoterapia, isso pode parecer evitamento, dissociação ou baixa implicação, quando às vezes o paciente simplesmente não consegue recuperar o episódio com nitidez. A discriminação depende de comparar com o padrão habitual de memória autobiográfica e de verificar se a lacuna está circunscrita ao período próximo do uso ou se se estende para além dele.

Contexto médico: Midazolam costuma entrar na história em cenários de exame, internação, procedimento ou crise aguda, e o impacto subjetivo do contexto frequentemente pesa mais na sessão do que o fármaco em si. Ansiedade antecipatória, sensação de vulnerabilidade corporal, medo de perder controle e dependência temporária da equipe podem organizar o relato e a transferência. Se o terapeuta atribui tudo ao medicamento, pode perder elementos centrais do sofrimento ligado à condição clínica, ao ambiente hospitalar ou à experiência de ter precisado de contenção química.

Uso episódico e adesão: Como tende a aparecer em uso pontual, o dado decisivo é entender se houve administração supervisionada em contexto assistencial ou uso por conta própria fora desse enquadre. Oscilações entre sessões podem refletir não apenas o efeito sedativo breve, mas também repetição de uso em momentos de angústia, associação com álcool ou outras substâncias e dificuldade de relatar com precisão quando foi utilizado. O terapeuta ganha mais ao mapear padrão, contexto e função subjetiva do uso do que ao tentar inferir causalidade linear a partir de uma sessão isolada.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Cloridrato de midazolam é um benzodiazepínico de ação curta, mais associado a sedação procedural, uso hospitalar e manejo pontual de agitação ou insônia em contextos específicos do que ao acompanhamento ambulatorial contínuo em psicoterapia. Quando aparece no consultório, costuma ser em torno de exames, internações, crises agudas ou uso episódico prescrito por outro contexto assistencial. O que mais importa ao terapeuta é situar a sessão em relação ao momento do uso: nas horas seguintes pode haver sonolência, lentificação, fala menos organizada e memória fragmentada; no dia seguinte ainda pode restar rebaixamento subjetivo. A observação central é diferenciar efeito sedativo transitório, sofrimento do contexto médico e uso irregular ou não combinado com outras substâncias.

Perguntas úteis

- "O que em você hoje parece sonolência e lentidão diferentes do seu jeito habitual, e o que parece mais ligado ao que aconteceu nesse contexto médico? , As partes que ficaram confusas ou em branco se concentram nas horas em torno do uso, ou você percebe esse apagamento também em outros momentos sem relação com ele? , Quando você pensa nesse episódio, o que pesa mais na sua experiência: o efeito de ficar sedado, o medo do procedimento, ou algo que aconteceu com a equipe ou com seu corpo? , Esse uso aconteceu só naquela situação específica ou você percebe que tem recorrido a isso em outros momentos de tensão, insônia ou crise? , Hoje sua dificuldade de se concentrar se parece com cansaço e sono, ou com aceleração ansiosa em que a cabeça não fixa em nada?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente às sessões sob efeito sedativo
- com prejuízo claro de atenção
- memória ou participação
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o impacto funcional desse padrão
- Quando surgem lacunas de memória
- desorganização temporal ou versões muito inconsistentes do uso
- pode valer comunicar o médico para esclarecer contexto
- frequência e possíveis associações com outras substâncias
- Quando o paciente passa a relatar uso fora de contexto assistencial
- especialmente como resposta recorrente a angústia
- insônia ou crises
- pode valer contato com o médico pela possibilidade de escalada silenciosa do uso
- Quando há piora importante do funcionamento no dia seguinte ao uso
- com quedas
- confusão ou incapacidade de retomar atividades habituais
- pode valer alinhar com o médico para avaliação clínica do impacto observado

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão há rebaixamento acentuado do nível de consciência
- dificuldade de manter-se desperto
- fala muito desconexa ou incapacidade de responder de modo minimamente consistente.: Interromper a exploração psicoterápica
- avaliar necessidade de apoio imediato e acionar atendimento médico no mesmo dia
- além da rede de apoio quando pertinente
- O paciente relata ter combinado o uso com álcool ou outras substâncias e se apresenta confuso

Vermelho: tratar como urgência

- muito sedado ou fisicamente instável.: Tratar como situação de risco agudo
- não manter a sessão como habitual e acionar avaliação médica imediata e suporte de segurança

Frase clínica

O foco é situar sedação, memória fragmentada e contexto médico sem confundir efeito breve com retraimento psíquico ou piora do quadro.

018 MIDAZOLAM

Substância: Midazolam.

Nomes Comerciais: Prontomid, Midazolam, Hypozam, Dormium

Uso comum

- Midazolam é um benzodiazepínico de ação curta, mais associado a sedação procedural, indução do sono em contexto agudo ou uso pontual do que a manejo psicoterápico contínuo. Quando aparece no consultório, costuma ser em pacientes que o utilizaram recentemente para exames, internações, crises agudas ou, às vezes, de modo intermitente para dormir. O que mais importa ao terapeuta é a janela muito próxima ao uso: nas horas seguintes podem surgir sonolência, lentificação, fala mais arrastada, menor acesso mnésico e menor elaboração; no dia seguinte ainda pode haver resquício subjetivo em parte dos pacientes. Se houver uso repetido ou irregular, vale acompanhar oscilação entre sedação, esquecimento do que ocorreu e busca de alívio rápido, sem assumir que toda apatia ou confusão venha do medicamento.

O paciente pode relatar

- **"Sedação na sessão:** O paciente pode chegar mais sonolento, com atenção flutuante, latência de resposta aumentada e menor capacidade de sustentar associação livre ou reflexão mais complexa. Na sessão, isso pode se parecer com retraimento depressivo, exaustão por privação de sono ou efeito de outras medicações sedativas. A discriminação costuma depender da proximidade temporal com o uso, da mudança em relação ao baseline e do caráter mais global da lentificação, que tende a afetar fala, memória imediata e responsividade ao longo de toda a hora.

Memória e continuidade: Após uso recente, alguns pacientes descrevem lacunas do que viveram, dificuldade de reconstituir conversas ou sensação de que o período ficou pouco nítido. Isso pode confundir a leitura do terapeuta sobre evitamento, resistência, dissociação ou desorganização emocional, especialmente se a sessão ocorre no mesmo dia ou no dia seguinte a um procedimento. Vale observar se a quebra de continuidade é circunscrita a uma janela temporal específica ou se já vinha aparecendo antes, em outros contextos, o que muda bastante a hipótese clínica.

Uso pontual e alívio rápido: Quando o midazolam entra na história como recurso para apagar, dormir ou atravessar momentos de intensa ativação, pode aparecer na sessão uma relação mais instrumental com o alívio imediato. Isso não deve ser lido automaticamente como dependência ou má-fé, mas pode competir com o trabalho de simbolização e com a tolerância a estados internos difíceis. Também é fácil confundir melhora transitória do sofrimento com elaboração clínica, quando na verdade houve apenas interrupção aguda da experiência subjetiva.

Adesão e uso fora do combinado: Por ser um medicamento frequentemente usado em contextos específicos, o terapeuta pode encontrar narrativas vagas sobre quando foi tomado, em que situação e com que regularidade. Oscilações entre noites muito sedadas, dias de maior lentificação e períodos sem uso podem parecer instabilidade do quadro de base, quando às vezes refletem padrão irregular de utilização ou associação com álcool e outros sedativos. O ponto clínico não é investigar tecnicamente o regime, mas mapear consistência do relato, contexto de uso e impacto funcional percebido pelo paciente."

O que observar em sessão

- **Sedação na sessão:** O paciente pode chegar mais sonolento, com atenção flutuante, latência de resposta aumentada e menor capacidade de sustentar associação livre ou reflexão mais complexa. Na sessão, isso pode se parecer com retraimento depressivo, exaustão por privação de sono ou efeito de outras medicações sedativas. A discriminação costuma depender da proximidade temporal com o uso, da mudança em relação ao baseline e do caráter mais global da lentificação, que tende a afetar fala, memória imediata e responsividade ao longo de toda a hora.

Memória e continuidade: Após uso recente, alguns pacientes descrevem lacunas do que viveram, dificuldade de reconstituir conversas ou sensação de que o período ficou pouco nítido. Isso pode confundir a leitura do terapeuta sobre evitamento, resistência, dissociação ou desorganização emocional, especialmente se a sessão ocorre no mesmo dia ou no dia seguinte a um procedimento. Vale observar se a quebra de continuidade é circunscrita a uma janela temporal específica ou se já vinha aparecendo antes, em outros contextos, o que muda bastante a hipótese clínica.

Uso pontual e alívio rápido: Quando o midazolam entra na história como recurso para apagar, dormir ou atravessar momentos de intensa ativação, pode aparecer na sessão uma relação mais instrumental com o alívio imediato. Isso não deve ser lido automaticamente como dependência ou má-fé, mas pode competir com o trabalho de simbolização e com a tolerância a estados internos difíceis. Também é fácil confundir melhora transitória do sofrimento com elaboração clínica, quando na verdade houve apenas interrupção aguda da experiência subjetiva.

Adesão e uso fora do combinado: Por ser um medicamento frequentemente usado em contextos específicos, o terapeuta pode encontrar narrativas vagas sobre quando foi tomado, em que situação e com que regularidade. Oscilações entre noites muito sedadas, dias de maior lentificação e períodos sem uso podem parecer instabilidade do quadro de base, quando às vezes refletem padrão irregular de utilização ou associação com álcool e outros sedativos. O ponto clínico não é investigar tecnicamente o regime, mas mapear consistência do relato, contexto de uso e impacto funcional percebido pelo paciente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Midazolam é um benzodiazepínico de ação curta, mais associado a sedação procedural, indução do sono em contexto agudo ou uso pontual do que a manejo psicoterápico contínuo. Quando aparece no consultório, costuma ser em pacientes que o utilizaram recentemente para exames, internações, crises agudas ou, às vezes, de modo intermitente para dormir. O que mais importa ao terapeuta é a janela muito próxima ao uso: nas horas seguintes podem surgir sonolência, lentificação, fala mais arrastada, menor acesso mnésico e menor elaboração; no dia seguinte ainda pode haver resquício subjetivo em parte dos pacientes. Se houver uso repetido ou irregular, vale acompanhar oscilação entre sedação, esquecimento do que ocorreu e busca de alívio rápido, sem assumir que toda apatia ou confusão venha do medicamento.

Perguntas úteis

- "Quando você ficou mais apagado ou lento, isso começou depois de usar o remédio ou já vinha aparecendo antes, em dias em que não houve uso? , Essas lacunas do que aconteceu ficam concentradas em um período específico depois de tomar o medicamento ou você percebe esse tipo de branco também em outras situações de estresse? , Quando você diz que o remédio ajudou, a sensação foi mais de conseguir descansar e desligar ou de realmente se sentir emocionalmente melhor no dia seguinte? , Nos dias em que você usa, as pessoas à sua volta notam você mais sonolento, confuso ou diferente do seu jeito habitual? , Quando a angústia aumenta, a ideia de tomar algo para apagar aparece como exceção em momentos muito intensos ou tem virado uma resposta mais frequente?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente à sessão muito sedado
- com fala arrastada ou dificuldade de se manter desperto
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer o peso do uso recente e o impacto funcional
- Quando surgem lacunas de memória
- confusão sobre eventos recentes ou dificuldade recorrente de reconstruir o que ocorreu após o uso
- pode valer comunicar o médico para avaliação da tolerabilidade e da segurança do contexto de uso
- Quando o paciente passa a descrever uso cada vez mais frequente como forma principal de lidar com angústia
- insônia ou crises
- pode valer alinhar com o médico pela mudança do padrão de enfrentamento e pelo risco de abandono silencioso de outras estratégias
- Quando há relato de associação com álcool ou outros medicamentos sedativos e o paciente minimiza o impacto
- pode valer comunicação com o médico pela possibilidade de intensificação da sedação e prejuízo de segurança

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente mal consegue se manter acordado
- responde de forma muito reduzida ou parece progressivamente menos responsivo.: Interromper o trabalho habitual
- avaliar segurança imediata
- acionar acompanhante ou rede de apoio e buscar avaliação médica no mesmo dia

Vermelho: tratar como urgência

- Há uso recente associado a álcool ou outro sedativo e o paciente se apresenta marcadamente rebaixado
- confuso ou sem condições de ir embora com segurança.: Não encerrar como uma sessão rotineira; providenciar suporte imediato
- contato com acompanhante e encaminhamento para avaliação urgente

Frase clínica

Com midazolam, o foco na terapia é distinguir sedação e lacunas de memória de mudanças reais do quadro e mapear padrão de uso recente.

019 BUPRENORFINA

Substância: Buprenorfina.

Nomes Comerciais: Buprenorfina, Lusanda, Transtec, Restiva

Uso comum

- Buprenorfina é um opioide usado sobretudo em manejo de dor moderada a intensa, muitas vezes em contexto de dor crônica e tratamento prolongado. No consultório de terapia, ela tende a aparecer menos como tema farmacológico isolado e mais como parte de um quadro em que dor, sono, funcionalidade, humor e rotina já estão pressionados. Mudanças subjetivas podem surgir nos primeiros dias após início ou alteração recente do uso, enquanto oscilações ao longo de semanas costumam se misturar à própria evolução da dor, ao cansaço acumulado e ao uso irregular. O ponto central na sessão é diferenciar sedação, lentificação e embotamento ligados ao tratamento da retração produzida pela dor crônica, além de notar sinais de uso errático ou sofrimento crescente.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e vigília:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer sonolência, fala mais lenta, redução de iniciativa e menor prontidão associativa. Isso pode se confundir com exaustão por dor persistente, noites mal dormidas, humor deprimido ou uso concomitante de outros agentes sedativos. Vale observar se a lentificação apareceu junto com mudança recente no padrão de uso, se varia conforme o horário da sessão ou se já vinha se instalando antes como parte do quadro clínico.

Dor e funcionalidade: Quando a dor está no centro da vida psíquica, pequenas mudanças na intensidade dolorosa podem alterar muito o acesso afetivo, a tolerância à frustração e a disponibilidade para elaboração. Às vezes o paciente parece mais recolhido não por piora depressiva, mas porque está organizando o dia em torno de suportar a dor; em outros casos, uma aparente melhora encobre sobrecarga funcional e esforço para manter rotina. A leitura fica mais precisa quando se acompanha o que mudou concretamente em sono, deslocamentos, autocuidado e capacidade de sustentar tarefas entre sessões.

Humor e reatividade: Dor crônica e opioides podem coexistir com irritabilidade, oscilação de humor, apatia ou sensação de estar emocionalmente amortecido. Na sessão, isso pode parecer desinvestimento, menor ressonância afetiva ou reatividade reduzida, mas também pode refletir alívio parcial da dor depois de um período de sofrimento intenso. Convém discriminar se houve empobrecimento afetivo novo, se o paciente ainda consegue se mobilizar diante de temas importantes e se a mudança acompanha eventos de vida, piora da dor ou padrão irregular de uso.

Cognição e presença: Alguns pacientes descrevem cabeça mais lenta, dificuldade de concentração, lapsos de memória recente ou sensação de estar menos nítidos. Em terapia, isso pode aparecer como perda do fio, necessidade de repetição, menor capacidade reflexiva ou dificuldade para sustentar associações, mas também pode decorrer de privação de sono, estresse crônico, ansiedade elevada ou sobrecarga pela própria condição dolorosa. O dado mais útil costuma ser a comparação com a baseline cognitiva do paciente e com o funcionamento fora da sessão.

Uso irregular e ambivalência: Em tratamentos prolongados, a adesão pode oscilar por medo de dependência, vergonha, tentativa de suportar a dor sem medicação, efeitos subjetivos incômodos ou dificuldade prática com a rotina de uso. Isso pode produzir um padrão confuso em sessão, com dias de maior sedação alternando com piora abrupta de dor, irritabilidade, inquietação ou mal-estar inespecífico. Mais do que supor causalidade, ajuda mapear regularidade, esquecimentos, interrupções por conta própria e o lugar simbólico que o medicamento ocupa na experiência do paciente."

O que observar em sessão

- **Sedação e vigília:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer sonolência, fala mais lenta, redução de iniciativa e menor prontidão associativa. Isso pode se confundir com exaustão por dor persistente, noites mal dormidas, humor deprimido ou uso concomitante de outros agentes sedativos. Vale observar se a lentificação apareceu junto com mudança recente no padrão de uso, se varia conforme o horário da sessão ou se já vinha se instalando antes como parte do quadro clínico.

Dor e funcionalidade: Quando a dor está no centro da vida psíquica, pequenas mudanças na intensidade dolorosa podem alterar muito o acesso afetivo, a tolerância à frustração e a disponibilidade para elaboração. Às vezes o paciente parece mais recolhido não por piora depressiva, mas porque está organizando o dia em torno de suportar a dor; em outros casos, uma aparente melhora encobre sobrecarga funcional e esforço para manter rotina. A leitura fica mais precisa quando se acompanha o que mudou concretamente em sono, deslocamentos, autocuidado e capacidade de sustentar tarefas entre sessões.

Humor e reatividade: Dor crônica e opioides podem coexistir com irritabilidade, oscilação de humor, apatia ou sensação de estar emocionalmente amortecido. Na sessão, isso pode parecer desinvestimento, menor ressonância afetiva ou reatividade reduzida, mas também pode refletir alívio parcial da dor depois de um período de sofrimento intenso. Convém discriminar se houve empobrecimento afetivo novo, se o paciente ainda consegue se mobilizar diante de temas importantes e se a mudança acompanha eventos de vida, piora da dor ou padrão irregular de uso.

Cognição e presença: Alguns pacientes descrevem cabeça mais lenta, dificuldade de concentração, lapsos de memória recente ou sensação de estar menos nítidos. Em terapia, isso pode aparecer como perda do fio, necessidade de repetição, menor capacidade reflexiva ou dificuldade para sustentar associações, mas também pode decorrer de privação de sono, estresse crônico, ansiedade elevada ou sobrecarga pela própria condição dolorosa. O dado mais útil costuma ser a comparação com a baseline cognitiva do paciente e com o funcionamento fora da sessão.

Uso irregular e ambivalência: Em tratamentos prolongados, a adesão pode oscilar por medo de dependência, vergonha, tentativa de suportar a dor sem medicação, efeitos subjetivos incômodos ou dificuldade prática com a rotina de uso. Isso pode produzir um padrão confuso em sessão, com dias de maior sedação alternando com piora abrupta de dor, irritabilidade, inquietação ou mal-estar inespecífico. Mais do que supor causalidade, ajuda mapear regularidade, esquecimentos, interrupções por conta própria e o lugar simbólico que o medicamento ocupa na experiência do paciente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Buprenorfina é um opioide usado sobretudo em manejo de dor moderada a intensa, muitas vezes em contexto de dor crônica e tratamento prolongado. No consultório de terapia, ela tende a aparecer menos como tema farmacológico isolado e mais como parte de um quadro em que dor, sono, funcionalidade, humor e rotina já estão pressionados. Mudanças subjetivas podem surgir nos primeiros dias após início ou alteração recente do uso, enquanto oscilações ao longo de semanas costumam se misturar à própria evolução da dor, ao cansaço acumulado e ao uso irregular. O ponto central na sessão é diferenciar sedação, lentificação e embotamento ligados ao tratamento da retração produzida pela dor crônica, além de notar sinais de uso errático ou sofrimento crescente.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais desligado ou lento, isso costuma vir junto com alívio da dor, com piora do cansaço ou sem relação clara com nenhum dos dois? , Nos dias em que a dor piora, você se percebe mais triste e sem energia o dia todo, ou mais tomado pela necessidade de suportar o corpo? , Essa sensação de estar menos presente apareceu de forma mais contínua nas últimas semanas ou varia bastante de um dia para outro? , Quando você deixa de usar como estava acostumado ou atrasa o uso, o que muda primeiro: a dor, o humor, o sono ou uma sensação corporal de mal-estar? , Seu afastamento afetivo tem mais a ver com menos interesse pelas pessoas e pelos temas da sua vida, ou com dificuldade de se engajar porque o corpo está exigindo atenção o tempo todo?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- confuso ou com fala marcadamente lentificada
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar se há relação com o tratamento ou com outras medicações em uso
- Quando surgem interrupções frequentes
- uso errático ou ambivalência importante que o paciente vinha omitindo
- pode valer comunicar o médico para reduzir risco de piora da dor
- mal-estar e abandono silencioso do tratamento
- Quando há piora funcional importante apesar de uso em curso por algumas semanas
- sem ganho subjetivo claro em dor ou rotina
- pode valer alinhar com o médico para contextualizar a evolução observada
- Quando aparecem sinais de humor progressivamente mais rebaixado
- retraimento acentuado ou perda de engajamento que não se explicam bem por eventos de vida
- pode valer comunicação para avaliação conjunta do quadro
- Quando o paciente relata associação com álcool ou outros sedativos e isso coincide com maior lentificação ou rebaixamento de vigília

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer contato com o médico pela relevância clínica imediata

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente aparece muito difícil de despertar
- com fala arrastada
- confusão evidente ou parece adormecer repetidamente enquanto fala.: Interrompa o trabalho clínico usual e acione avaliação médica no mesmo dia; se houver rebaixamento importante de consciência ou risco clínico imediato
- acione emergência e rede de apoio
- Surge ideação suicida com intenção
- plano ou sensação de perda de controle
- especialmente em contexto de dor intensa
- desesperança e acesso a medicações.: Faça manejo de risco imediatamente
- acione rede de apoio e avaliação médica urgente no mesmo dia
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

Com buprenorfina, o foco clínico é separar o peso da dor crônica da sedação e da lentificação que podem alterar presença, humor e adesão.

020 CLORIDRATO DE METADONA

Substância: Cloridrato de Metadona.

Nomes Comerciais: Mytedom

Uso comum

- Cloridrato de metadona é um opioide usado sobretudo em manejo de dor crônica e, em alguns contextos, em tratamento de dependência de opioides. No consultório de terapia, costuma aparecer menos pelo nome do fármaco e mais por mudanças em vigília, ritmo psíquico, constância de presença e relação do paciente com dor, alívio e funcionamento diário. Sedação, lentificação, constipação e oscilação de energia podem surgir desde o início ou após mudanças recentes no tratamento; uso irregular ou interrupção pode se traduzir em mal-estar, inquietação e piora abrupta da tolerância emocional em horas a poucos dias. O ponto central é diferenciar efeito do medicamento, flutuação da dor, abstinência, uso concomitante de outras substâncias e sofrimento psíquico de base.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e vigília:** Em sessão, o paciente pode chegar mais sonolento, com fala lenta, atenção flutuante ou dificuldade de sustentar elaboração, especialmente em horários próximos ao uso. Isso pode ser confundido com depressão, exaustão por dor crônica, privação de sono ou uso concomitante de benzodiazepínicos, álcool e outros sedativos. Vale observar se a lentificação varia ao longo do dia, se é nova em relação à baseline e se compromete presença, memória da sessão ou segurança no deslocamento.

Dor e funcionamento: Quando a dor está mais controlada, alguns pacientes retomam atividades e ficam mais disponíveis afetivamente; em outros, o alívio parcial expõe frustração, luto funcional e conflitos antes encobertos pela crise dolorosa. O inverso também ocorre: piora da dor pode parecer recaída depressiva ou irritabilidade primária. Na leitura clínica, ajuda mapear se a oscilação emocional acompanha a intensidade da dor, a qualidade do sono e a capacidade de cumprir rotinas básicas.

Abstinência e uso irregular: Aderência irregular pode aparecer como faltas, atraso, inquietação corporal, sudorese, bocejos, irritabilidade, queixa de mal-estar difuso e queda abrupta da tolerância a frustração. Esse quadro pode ser lido apressadamente como ansiedade, crise de pânico, desorganização de personalidade ou agravamento do quadro de base. O dado mais útil costuma ser a relação temporal entre esses sinais e esquecimentos, mudanças na rotina, dificuldade de acesso ao medicamento ou uso de outras substâncias.

Humor e reatividade: O uso pode coexistir com embotamento, redução da reatividade emocional ou, em contraste, maior irritabilidade quando há dor, privação de sono ou oscilação de uso. Em sessão, isso às vezes se parece com melhora genuína por menor sofrimento físico, e em outras com afastamento afetivo pouco elaborado. Convém discriminar se houve ampliação real de interesse e vínculo ou apenas menor expressão emocional acompanhada de lentificação e menor acesso reflexivo.

Cognição e memória: Alguns pacientes descrevem cabeça lenta, dificuldade de concentração e lapsos de memória recente, o que interfere na continuidade do trabalho terapêutico. Isso pode decorrer do próprio medicamento, da dor crônica, do sono fragmentado, de humor deprimido ou de poliuso de substâncias. Mais do que atribuir causa, importa registrar se a mudança é nova, se oscila conforme o horário e se está afetando decisões, autocuidado e capacidade de seguir combinados."

O que observar em sessão

- **Sedação e vigília:** Em sessão, o paciente pode chegar mais sonolento, com fala lenta, atenção flutuante ou dificuldade de sustentar elaboração, especialmente em horários próximos ao uso. Isso pode ser confundido com depressão, exaustão por dor crônica, privação de sono ou uso concomitante de benzodiazepínicos, álcool e outros sedativos. Vale observar se a lentificação varia ao longo do dia, se é nova em relação à baseline e se compromete presença, memória da sessão ou segurança no deslocamento.

Dor e funcionamento: Quando a dor está mais controlada, alguns pacientes retomam atividades e ficam mais disponíveis afetivamente; em outros, o alívio parcial expõe frustração, luto funcional e conflitos antes encobertos pela crise dolorosa. O inverso também ocorre: piora da dor pode parecer recaída depressiva ou irritabilidade primária. Na leitura clínica, ajuda mapear se a oscilação emocional acompanha a intensidade da dor, a qualidade do sono e a capacidade de cumprir rotinas básicas.

Abstinência e uso irregular: Aderência irregular pode aparecer como faltas, atraso, inquietação corporal, sudorese, bocejos, irritabilidade, queixa de mal-estar difuso e queda abrupta da tolerância a frustração. Esse quadro pode ser lido apressadamente como ansiedade, crise de pânico, desorganização de personalidade ou agravamento do quadro de base. O dado mais útil costuma ser a relação temporal entre esses sinais e esquecimentos, mudanças na rotina, dificuldade de acesso ao medicamento ou uso de outras substâncias.

Humor e reatividade: O uso pode coexistir com embotamento, redução da reatividade emocional ou, em contraste, maior irritabilidade quando há dor, privação de sono ou oscilação de uso. Em sessão, isso às vezes se parece com melhora genuína por menor sofrimento físico, e em outras com afastamento afetivo pouco elaborado. Convém discriminar se houve ampliação real de interesse e vínculo ou apenas menor expressão emocional acompanhada de lentificação e menor acesso reflexivo.

Cognição e memória: Alguns pacientes descrevem cabeça lenta, dificuldade de concentração e lapsos de memória recente, o que interfere na continuidade do trabalho terapêutico. Isso pode decorrer do próprio medicamento, da dor crônica, do sono fragmentado, de humor deprimido ou de poliuso de substâncias. Mais do que atribuir causa, importa registrar se a mudança é nova, se oscila conforme o horário e se está afetando decisões, autocuidado e capacidade de seguir combinados.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Cloridrato de metadona é um opioide usado sobretudo em manejo de dor crônica e, em alguns contextos, em tratamento de dependência de opioides. No consultório de terapia, costuma aparecer menos pelo nome do fármaco e mais por mudanças em vigília, ritmo psíquico, constância de presença e relação do paciente com dor, alívio e funcionamento diário. Sedação, lentificação, constipação e oscilação de energia podem surgir desde o início ou após mudanças recentes no tratamento; uso irregular ou interrupção pode se traduzir em mal-estar, inquietação e piora abrupta da tolerância emocional em horas a poucos dias. O ponto central é diferenciar efeito do medicamento, flutuação da dor, abstinência, uso concomitante de outras substâncias e sofrimento psíquico de base.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso costuma acontecer em algum período previsível do dia ou aparece de forma mais solta, independentemente do horário? , Nos dias em que você fica mais irritado ou angustiado, isso vem junto com piora da dor, com sensação de mal-estar no corpo, ou parece mais ligado a situações da sua vida? , Essa sensação de estar mais 'apagado' parece um alívio por sofrer menos ou vem junto com dificuldade de sentir interesse, proximidade e acesso ao que você pensa? , Quando você perde uma tomada, atrasa ou muda sua rotina, o que costuma acontecer com seu corpo, seu humor e sua capacidade de funcionar nas horas seguintes? , Sua dificuldade de atenção e memória está parecida ao longo da semana ou varia conforme sono, dor, horário do dia ou uso de outras substâncias?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente muito sonolento
- com fala arrastada ou dificuldade de se manter desperto em sessão
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar segurança e impacto funcional do tratamento
- Quando surgem sinais consistentes de uso irregular
- interrupções frequentes ou mal-estar recorrente associado a esquecimentos
- pode valer comunicar o médico para avaliação de adesão e risco de descontinuidade
- Quando a dor permanece muito alta e o paciente relata pouco ganho funcional após um período de acompanhamento
- pode valer contato com o médico para situar a persistência do sofrimento e seu impacto psíquico
- Quando há piora cognitiva nítida
- lapsos de memória ou confusão novos em relação à baseline
- especialmente com suspeita de poliuso de sedativos ou álcool
- pode valer alinhar com o médico pela repercussão clínica
- Quando o paciente passa a evitar silenciosamente o tratamento por sedação
- constipação ou sensação de embotamento
- pode valer comunicar o médico porque esses efeitos podem favorecer abandono não dito

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente mal consegue se manter acordado
- tem fala muito arrastada
- parece confuso ou relata episódios recentes de quase desmaio ou respiração muito lenta.: Interrompa o foco psicoterápico

Vermelho: tratar como urgência

- avalie segurança imediata e acione no mesmo dia o médico
- rede de apoio ou emergência conforme a gravidade observada
- Há combinação de sonolência importante com uso recente de álcool
- benzodiazepínicos ou outros sedativos
- acompanhada de rebaixamento de responsividade.: Trate como situação de risco agudo
- mantenha o paciente assistido e acione imediatamente suporte médico e rede de apoio; emergência pode ser necessária
- Surge ideação suicida com plano ou intenção
- especialmente em contexto de dor intensa
- desesperança e acesso a medicação potencialmente perigosa em uso inadequado.: Faça manejo de risco no mesmo dia
- acione rede de apoio e médico assistente
- e encaminhe para emergência quando houver risco iminente

Frase clínica

O foco clínico é distinguir sedação, abstinência e flutuação da dor de mudanças primárias do humor, da cognição e da adesão.

021 CLORIDRATO DE OXICODONA; CLORIDRATO DE NALOXONA

Substância: Cloridrato de Oxycodona; Cloridrato de Naloxona.

Nomes Comerciais: Targin

Uso comum

- Combinação analgésica usada sobretudo em dor crônica moderada a intensa, muitas vezes em pacientes com longa trajetória de tratamento e impacto funcional importante. No consultório, o foco costuma ser menos a medicação em si e mais como o manejo contínuo da dor, do sono e da rotina repercute no humor, na atenção e no vínculo terapêutico. Mudanças subjetivas podem aparecer nos primeiros dias após início ou retomada, e oscilações ao longo de semanas podem refletir tanto adaptação ao tratamento quanto variação da dor, piora clínica, uso irregular ou associação com outras substâncias sedativas. Vale acompanhar especialmente sedação, lentificação, constipação com repercussão no bem-estar, e sinais de uso fora do padrão combinado.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e presença:** Em parte dos pacientes, a sessão fica marcada por sonolência, fala mais lenta, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar atenção. Isso pode ser confundido com humor deprimido, exaustão por dor crônica, privação de sono ou uso concomitante de outras medicações sedativas. A leitura clínica ganha precisão quando se observa se a lentificação varia conforme o horário da tomada, se já estava presente antes e se aparece junto de alívio da dor ou, ao contrário, de maior sofrimento corporal.

Dor e humor: Quando a dor cede parcialmente, alguns pacientes chegam mais disponíveis, menos irritáveis e com maior tolerância afetiva; em outros, a frustração por alívio incompleto mantém desesperança e retraimento. Na sessão, isso pode parecer melhora depressiva, piora do quadro de base ou simples oscilação ligada a dias melhores e piores de dor. Vale discriminar se a mudança emocional acompanha a intensidade da dor e a funcionalidade cotidiana, ou se segue curso relativamente independente desses fatores.

Cognição funcional: Pode surgir sensação de cabeça lenta, dificuldade de organizar pensamento, lapsos atencionais e menor agilidade para elaborar. Esses achados também aparecem em dor persistente, noites ruins, sobrecarga emocional e estresse crônico, o que torna arriscado atribuí-los de imediato ao medicamento. O terapeuta se beneficia de comparar com a baseline cognitiva do paciente e notar se a oscilação é estável, progressiva ou concentrada em certos períodos do dia.

Uso irregular e padrão de busca: Em dor crônica, nem sempre o uso segue um padrão estável, e o paciente pode alternar dias de maior necessidade, esquecimento, antecipação por medo da dor ou redução silenciosa por efeitos incômodos. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação abrupta de humor, energia e presença, sem que a narrativa inicialmente conecte esses movimentos ao modo de uso. Também merece atenção quando a conversa passa a girar de forma estreita em torno da medicação, da próxima dose ou do receio intenso de ficar sem ela, porque isso muda a leitura clínica do sofrimento.

Sono e rotina: Alguns pacientes relatam melhora do sono quando a dor noturna reduz; outros ficam mais sonolentos durante o dia, com rotina desorganizada e menor engajamento. Esse quadro pode ser lido como efeito do tratamento, mas também como consequência de dor mal controlada, insônia prévia, apneia, ansiedade ou hábitos de sono já comprometidos. Observar o encadeamento entre dor, cochilos diurnos, funcionamento matinal e capacidade de comparecer psicologicamente à sessão ajuda a diferenciar hipóteses."

O que observar em sessão

- **Sedação e presença:** Em parte dos pacientes, a sessão fica marcada por sonolência, fala mais lenta, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar atenção. Isso pode ser confundido com humor deprimido, exaustão por dor crônica, privação de sono ou uso concomitante de outras medicações sedativas. A leitura clínica ganha precisão quando se observa se a lentificação varia conforme o horário da tomada, se já estava presente antes e se aparece junto de alívio da dor ou, ao contrário, de maior sofrimento corporal.

Dor e humor: Quando a dor cede parcialmente, alguns pacientes chegam mais disponíveis, menos irritáveis e com maior tolerância afetiva; em outros, a frustração por alívio incompleto mantém desesperança e retraimento. Na sessão, isso pode parecer melhora depressiva, piora do quadro de base ou simples oscilação ligada a dias melhores e piores de dor. Vale discriminar se a mudança emocional acompanha a intensidade da dor e a funcionalidade cotidiana, ou se segue curso relativamente independente desses fatores.

Cognição funcional: Pode surgir sensação de cabeça lenta, dificuldade de organizar pensamento, lapsos atencionais e menor agilidade para elaborar. Esses achados também aparecem em dor persistente, noites ruins, sobrecarga emocional e estresse crônico, o que torna arriscado atribuí-los de imediato ao medicamento. O terapeuta se beneficia de comparar com a baseline cognitiva do paciente e notar se a oscilação é estável, progressiva ou concentrada em certos períodos do dia.

Uso irregular e padrão de busca: Em dor crônica, nem sempre o uso segue um padrão estável, e o paciente pode alternar dias de maior necessidade, esquecimento, antecipação por medo da dor ou redução silenciosa por efeitos incômodos. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação abrupta de humor, energia e presença, sem que a narrativa inicialmente conecte esses movimentos ao modo de uso. Também merece atenção quando a conversa passa a girar de forma estreita em torno da medicação, da próxima dose ou do receio intenso de ficar sem ela, porque isso muda a leitura clínica do sofrimento.

Sono e rotina: Alguns pacientes relatam melhora do sono quando a dor noturna reduz; outros ficam mais sonolentos durante o dia, com rotina desorganizada e menor engajamento. Esse quadro pode ser lido como efeito do tratamento, mas também como consequência de dor mal controlada, insônia prévia, apneia, ansiedade ou hábitos de sono já comprometidos. Observar o encadeamento entre dor, cochilos diurnos, funcionamento matinal e capacidade de comparecer psicologicamente à sessão ajuda a diferenciar hipóteses.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Combinação analgésica usada sobretudo em dor crônica moderada a intensa, muitas vezes em pacientes com longa trajetória de tratamento e impacto funcional importante. No consultório, o foco costuma ser menos a medicação em si e mais como o manejo contínuo da dor, do sono e da rotina repercute no humor, na atenção e no vínculo terapêutico. Mudanças subjetivas podem aparecer nos primeiros dias após início ou retomada, e oscilações ao longo de semanas podem refletir tanto adaptação ao tratamento quanto variação da dor, piora clínica, uso irregular ou associação com outras substâncias sedativas. Vale acompanhar especialmente sedação, lentificação, constipação com repercussão no bem-estar, e sinais de uso fora do padrão combinado.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso costuma acontecer em algum período específico do dia ou aparece de forma parecida o tempo todo? , Nos dias em que você chega mais abatido, isso acompanha aumento da dor, piora do sono ou parece acontecer mesmo quando a dor está mais controlada? , Essa dificuldade de concentração se parece com algo que você já tinha antes por cansaço e dor, ou surgiu de um jeito diferente depois que o tratamento mudou? , Quando você usa de um jeito diferente do habitual, o que muda primeiro em você: a dor, o humor, o sono, a clareza para pensar ou outra coisa? , Quando a medicação entra no centro da sua preocupação, o foco é evitar a dor, lidar com algum efeito incômodo ou o medo de ficar sem ela?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente muito sonolento
- lentificado ou com queda clara de atenção que interfere na sessão e na rotina
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar a tolerabilidade clínica e a segurança funcional
- Quando aparecem uso irregular
- antecipação frequente
- perda do padrão combinado ou dificuldade persistente de relatar como está usando
- pode valer comunicar o médico assistente para esclarecer o contexto e reduzir risco de manejo desorganizado
- Quando o paciente descreve piora importante de constipação
- náusea ou mal-estar corporal a ponto de comprometer alimentação
- sono ou adesão
- pode valer alinhar com o médico assistente porque esses fatores costumam repercutir diretamente no funcionamento psíquico e na continuidade do tratamento
- Quando há pouca resposta percebida após algumas semanas
- com dor ainda muito limitante e sofrimento emocional crescente
- pode valer comunicação com o médico assistente para situar a evolução clínica observada em sessão

Amarelo: alinhar em breve

- Quando surgem sinais de associação com álcool ou outros sedativos
- mesmo de forma esporádica
- pode valer contato com o médico assistente pela relevância para segurança e para a leitura do estado mental em sessão

Vermelho: tratar como urgência

- Paciente muito rebaixado
- difícil de despertar
- com fala arrastada importante
- confusão ou queda acentuada do nível de responsividade na sessão.: Interromper o enquadre habitual
- acionar suporte imediato e buscar avaliação médica urgente ou emergência conforme o contexto
- Relato de uso junto com álcool ou outros sedativos acompanhado de sonolência intensa
- desorientação ou sensação de quase desmaio.: Tratar como situação de risco agudo
- acionar rede de apoio e encaminhar para avaliação médica imediata
- Ideação suicida com plano ou intenção em contexto de dor intensa
- desesperança e acesso a medicação potencialmente perigosa em uso inadequado.: Fazer manejo de crise no mesmo dia
- acionar rede de apoio e avaliação urgente
- além de comunicar o médico assistente

Frase clínica

O ponto central é distinguir sofrimento da dor crônica, sedação e uso irregular quando a presença psíquica do paciente oscila na sessão.

022 FENTANILA

Substância: Fentanila.

Nomes Comerciais: Durogesic

Uso comum

- Fentanila é um opioide potente, mais frequentemente encontrado no consultório quando o paciente está em tratamento de dor intensa, muitas vezes crônica, inclusive em formulações de uso contínuo. Para o terapeuta, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como analgesia, sedação, lentificação, oscilação de atenção e dependência da rotina medicamentosa atravessam a sessão. Mudanças podem aparecer logo após início, troca de apresentação ou uso irregular, enquanto interrupções ou atrasos no uso podem ser seguidos, em horas a poucos dias, por mal-estar importante, agitação e piora global do funcionamento. Vale acompanhar a linha de base entre dor, vigília, afeto e adesão.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e vigília:** Em parte dos pacientes, a sessão fica marcada por sonolência, fala mais lenta, redução de iniciativa e dificuldade de sustentar elaboração mais complexa. Isso pode se confundir com exaustão pela dor crônica, privação de sono, humor deprimido ou uso concomitante de outros depressores do sistema nervoso central. A discriminação clínica costuma depender de observar se a lentificação varia ao longo do dia, se acompanha momentos próximos ao uso e se contrasta com a linha de base prévia do paciente.

Dor e funcionamento: Quando a analgesia melhora, alguns pacientes chegam mais disponíveis afetivamente e com maior tolerância à frustração; em outros, a dor persiste e ocupa a sessão, com irritabilidade, desesperança e retraimento. Nem toda piora emocional nesse contexto indica efeito da medicação: flutuações da condição dolorosa, perdas funcionais, conflitos familiares e fadiga acumulada podem pesar mais do que o medicamento. Vale notar se a mudança subjetiva acompanha alívio da dor, piora da dor ou um padrão mais errático ligado ao uso irregular.

Cognição e atenção: Pode aparecer dificuldade de concentração, memória de curto prazo mais falha, sensação de cabeça enevoada e menor capacidade de acompanhar encadeamentos na sessão. Esse quadro pode ser lido apressadamente como desorganização ansiosa, piora depressiva ou baixa motivação, quando às vezes está mais ligado à combinação entre dor, privação de sono e efeito sedativo. A observação clínica ganha precisão ao comparar desempenho entre sessões, checar variação intra-sessão e registrar se o paciente nota períodos mais nítidos e períodos mais embotados.

Adesão e uso irregular: Em opioides de uso contínuo, atrasos, esquecimentos, uso fora do padrão prescrito ou tentativas de reduzir por conta própria podem aparecer indiretamente como mal-estar, inquietação, piora abrupta da dor, irritabilidade ou sessão muito diferente do habitual. Isso pode ser confundido com recaída depressiva, crise de ansiedade ou reação a estressores recentes. Muitas vezes o dado decisivo é a cronologia: mudança súbita após falha no uso, dificuldade de manter regularidade ou silêncio do paciente por receio de julgamento.

Humor e reatividade: Alguns pacientes descrevem alívio emocional secundário ao controle da dor; outros mostram embotamento, menor acesso afetivo ou oscilação entre apatia e irritabilidade. Nem sempre isso decorre diretamente da fentanila: viver com dor persistente, limitação funcional, medo de piora clínica e dependência de cuidados pode reorganizar o humor por si só. Na sessão, ajuda diferenciar se houve ampliação real de repertório emocional e funcionalidade ou apenas redução inespecífica da reatividade."

O que observar em sessão

- **Sedação e vigília:** Em parte dos pacientes, a sessão fica marcada por sonolência, fala mais lenta, redução de iniciativa e dificuldade de sustentar elaboração mais complexa. Isso pode se confundir com exaustão pela dor crônica, privação de sono, humor deprimido ou uso concomitante de outros depressores do sistema nervoso central. A discriminação clínica costuma depender de observar se a lentificação varia ao longo do dia, se acompanha momentos próximos ao uso e se contrasta com a linha de base prévia do paciente.

Dor e funcionamento: Quando a analgesia melhora, alguns pacientes chegam mais disponíveis afetivamente e com maior tolerância à frustração; em outros, a dor persiste e ocupa a sessão, com irritabilidade, desesperança e retraimento. Nem toda piora emocional nesse contexto indica efeito da medicação: flutuações da condição dolorosa, perdas funcionais, conflitos familiares e fadiga acumulada podem pesar mais do que o medicamento. Vale notar se a mudança subjetiva acompanha alívio da dor, piora da dor ou um padrão mais errático ligado ao uso irregular.

Cognição e atenção: Pode aparecer dificuldade de concentração, memória de curto prazo mais falha, sensação de cabeça enevoada e menor capacidade de acompanhar encadeamentos na sessão. Esse quadro pode ser lido apressadamente como desorganização ansiosa, piora depressiva ou baixa motivação, quando às vezes está mais ligado à combinação entre dor, privação de sono e efeito sedativo. A observação clínica ganha precisão ao comparar desempenho entre sessões, checar variação intra-sessão e registrar se o paciente nota períodos mais nítidos e períodos mais embotados.

Adesão e uso irregular: Em opioides de uso contínuo, atrasos, esquecimentos, uso fora do padrão prescrito ou tentativas de reduzir por conta própria podem aparecer indiretamente como mal-estar, inquietação, piora abrupta da dor, irritabilidade ou sessão muito diferente do habitual. Isso pode ser confundido com recaída depressiva, crise de ansiedade ou reação a estressores recentes. Muitas vezes o dado decisivo é a cronologia: mudança súbita após falha no uso, dificuldade de manter regularidade ou silêncio do paciente por receio de julgamento.

Humor e reatividade: Alguns pacientes descrevem alívio emocional secundário ao controle da dor; outros mostram embotamento, menor acesso afetivo ou oscilação entre apatia e irritabilidade. Nem sempre isso decorre diretamente da fentanila: viver com dor persistente, limitação funcional, medo de piora clínica e dependência de cuidados pode reorganizar o humor por si só. Na sessão, ajuda diferenciar se houve ampliação real de repertório emocional e funcionalidade ou apenas redução inespecífica da reatividade.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Fentanila é um opioide potente, mais frequentemente encontrado no consultório quando o paciente está em tratamento de dor intensa, muitas vezes crônica, inclusive em formulações de uso contínuo. Para o terapeuta, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como analgesia, sedação, lentificação, oscilação de atenção e dependência da rotina medicamentosa atravessam a sessão. Mudanças podem aparecer logo após início, troca de apresentação ou uso irregular, enquanto interrupções ou atrasos no uso podem ser seguidos, em horas a poucos dias, por mal-estar importante, agitação e piora global do funcionamento. Vale acompanhar a linha de base entre dor, vigília, afeto e adesão.

Perguntas úteis

- "Quando você chega mais lento ou sonolento, isso costuma acontecer junto com mais alívio da dor, com noites ruins, ou sem um padrão claro para você? , Nos dias em que a dor piora de repente, você percebe também inquietação, mal-estar corporal ou irritabilidade fora do seu padrão habitual? , Essa sensação de cabeça enevoada aparece o tempo todo ou alterna com períodos em que você se sente mais nítido e consegue pensar melhor? , Quando você parece mais apático, isso vem com menos sofrimento porque a dor cedeu ou com sensação de estar desligado de tudo, inclusive do que importa para você? , Houve dias em que você usou de um jeito diferente do habitual, atrasou ou ficou sem, e depois percebeu uma mudança brusca no corpo, no humor ou na capacidade de funcionar?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- com fala arrastada e queda clara de atenção em comparação com a linha de base
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar a leitura clínica de sedação e segurança funcional
- Quando surgem uso irregular
- atrasos frequentes ou tentativas de reduzir por conta própria acompanhados de mal-estar e piora abrupta do funcionamento
- pode valer comunicar o médico para esclarecer se há impacto clínico relevante da adesão instável
- Quando a dor permanece muito intensa apesar do tratamento e a sessão fica dominada por desesperança
- retraimento e perda funcional progressiva
- pode valer contato com o médico para alinhar a leitura entre controle da dor e sofrimento psíquico
- Quando aparecem confusão
- oscilação importante de atenção ou mudança cognitiva nova que não se explica bem por eventos de vida ou pelo quadro psíquico habitual
- pode valer comunicação para avaliação médica mais próxima

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente parece excessivamente sedado
- muito difícil de despertar
- confuso ou com respiração visivelmente lenta.: Interromper o trabalho psicoterápico
- acionar suporte médico no mesmo dia e recorrer à emergência se o rebaixamento de consciência ou a lentidão respiratória forem relevantes

Vermelho: tratar como urgência

- Há ideação suicida com plano ou intenção em contexto de acesso a opioide e piora aguda do estado mental.: Fazer manejo imediato de risco
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- considerando emergência conforme a gravidade

Frase clínica

Com fentanila, o ponto central na terapia é distinguir analgesia e sedação de piora psíquica, além de captar cedo uso irregular e risco clínico.

023 SULFATO DE MORFINA

Substância: Sulfato de Morfina.

Nomes Comerciais: Dimorf, Sulfato de Morfina

Uso comum

- O sulfato de morfina é um opioide usado sobretudo em dor moderada a intensa, muitas vezes em contextos de dor crônica, dor oncológica ou fases de maior fragilidade clínica. No consultório de terapia, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como analgesia, sedação, lentificação, oscilação de atenção e medo de piora da dor reorganizam a vida psíquica e a sessão. Mudanças podem aparecer logo nos primeiros dias após início ou retomada, e também quando há uso irregular, esquecimento, redução por conta própria ou piora da dor de base. Vale acompanhar especialmente o equilíbrio entre alívio da dor, funcionalidade, clareza mental e risco de abandono silencioso.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e vigília:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter mais lentificação, sonolência, fala mais arrastada ou dificuldade de sustentar o fio associativo. Isso pode se confundir com exaustão pela própria dor, privação de sono, humor deprimido ou outras medicações sedativas em paralelo. A diferença clínica costuma aparecer quando o paciente descreve piora da presença mental em horários mais próximos do uso, com preservação relativa do interesse psíquico apesar da baixa vigília.

Dor e humor: Quando a dor cede, alguns pacientes chegam mais disponíveis, menos reativos e com maior acesso afetivo; em outros, o alívio parcial expõe luto, medo, desamparo ou frustração acumulados. O terapeuta pode confundir essa mudança com melhora global do quadro psíquico ou, no sentido oposto, com agravamento depressivo quando a dor segue ocupando a cena. Vale observar se a variação emocional acompanha a intensidade da dor, a funcionalidade e o quanto o sofrimento narrado se organiza em torno do corpo ou de temas mais amplos.

Cognição e ritmo: Pode surgir sensação de cabeça lenta, atenção flutuante, dificuldade de memória recente e menor agilidade para elaborar, sobretudo em fases de ajuste clínico, piora da dor ou noites mal dormidas. Na sessão, isso aparece como perda do encadeamento, necessidade de repetição e menor capacidade de simbolização naquele encontro. A leitura pode se confundir com rebaixamento depressivo, sobrecarga clínica, delirium em contexto médico mais complexo ou uso concomitante de outras substâncias; por isso, importa situar início, flutuação ao longo do dia e relação com o estado físico geral.

Adesão e uso irregular: Com opioides, o manejo subjetivo do uso costuma ser clinicamente relevante: alguns pacientes reduzem por medo de dependência, outros oscilam conforme a dor, e há quem silencie efeitos incômodos para não perder analgesia. Na terapia, isso pode aparecer como relato impreciso do padrão de uso, alternância entre dias muito sonolentos e dias de dor mais desorganizada, ou vergonha ao falar do medicamento. Sem assumir causalidade, vale diferenciar se a instabilidade da sessão acompanha eventos de vida e curso da doença ou um uso pouco consistente.

Constipação e corpo: Embora pareça tema médico, a constipação e o desconforto corporal associados ao uso podem ocupar muito espaço psíquico, aumentar irritabilidade, reduzir disposição para sair de casa e empobrecer a experiência de autonomia. O paciente pode chegar mais tomado pelo corpo, menos tolerante à frustração e com sensação de aprisionamento na rotina de sintomas. Isso às vezes é lido apenas como piora do humor, quando na prática há um componente somático persistente interferindo diretamente na disponibilidade emocional e na adesão ao tratamento."

O que observar em sessão

- **Sedação e vigília:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter mais lentificação, sonolência, fala mais arrastada ou dificuldade de sustentar o fio associativo. Isso pode se confundir com exaustão pela própria dor, privação de sono, humor deprimido ou outras medicações sedativas em paralelo. A diferença clínica costuma aparecer quando o paciente descreve piora da presença mental em horários mais próximos do uso, com preservação relativa do interesse psíquico apesar da baixa vigília.

Dor e humor: Quando a dor cede, alguns pacientes chegam mais disponíveis, menos reativos e com maior acesso afetivo; em outros, o alívio parcial expõe luto, medo, desamparo ou frustração acumulados. O terapeuta pode confundir essa mudança com melhora global do quadro psíquico ou, no sentido oposto, com agravamento depressivo quando a dor segue ocupando a cena. Vale observar se a variação emocional acompanha a intensidade da dor, a funcionalidade e o quanto o sofrimento narrado se organiza em torno do corpo ou de temas mais amplos.

Cognição e ritmo: Pode surgir sensação de cabeça lenta, atenção flutuante, dificuldade de memória recente e menor agilidade para elaborar, sobretudo em fases de ajuste clínico, piora da dor ou noites mal dormidas. Na sessão, isso aparece como perda do encadeamento, necessidade de repetição e menor capacidade de simbolização naquele encontro. A leitura pode se confundir com rebaixamento depressivo, sobrecarga clínica, delirium em contexto médico mais complexo ou uso concomitante de outras substâncias; por isso, importa situar início, flutuação ao longo do dia e relação com o estado físico geral.

Adesão e uso irregular: Com opioides, o manejo subjetivo do uso costuma ser clinicamente relevante: alguns pacientes reduzem por medo de dependência, outros oscilam conforme a dor, e há quem silencie efeitos incômodos para não perder analgesia. Na terapia, isso pode aparecer como relato impreciso do padrão de uso, alternância entre dias muito sonolentos e dias de dor mais desorganizada, ou vergonha ao falar do medicamento. Sem assumir causalidade, vale diferenciar se a instabilidade da sessão acompanha eventos de vida e curso da doença ou um uso pouco consistente.

Constipação e corpo: Embora pareça tema médico, a constipação e o desconforto corporal associados ao uso podem ocupar muito espaço psíquico, aumentar irritabilidade, reduzir disposição para sair de casa e empobrecer a experiência de autonomia. O paciente pode chegar mais tomado pelo corpo, menos tolerante à frustração e com sensação de aprisionamento na rotina de sintomas. Isso às vezes é lido apenas como piora do humor, quando na prática há um componente somático persistente interferindo diretamente na disponibilidade emocional e na adesão ao tratamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O sulfato de morfina é um opioide usado sobretudo em dor moderada a intensa, muitas vezes em contextos de dor crônica, dor oncológica ou fases de maior fragilidade clínica. No consultório de terapia, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como analgesia, sedação, lentificação, oscilação de atenção e medo de piora da dor reorganizam a vida psíquica e a sessão. Mudanças podem aparecer logo nos primeiros dias após início ou retomada, e também quando há uso irregular, esquecimento, redução por conta própria ou piora da dor de base. Vale acompanhar especialmente o equilíbrio entre alívio da dor, funcionalidade, clareza mental e risco de abandono silencioso.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais desligado ou sonolento, isso costuma acontecer junto com alívio da dor, em certos horários do dia, ou aparece mesmo quando a dor está igual? , Nos dias em que você parece mais abatido, o que pesa mais: tristeza e desesperança, dor e cansaço físico, ou sensação de estar mais lento e enevoado? , Quando sua atenção falha na sessão ou no dia a dia, isso vem como sono, confusão, distração pela dor ou dificuldade de organizar o pensamento? , Você percebe dias em que evita ou muda o uso por conta própria por medo, vergonha ou receio de ficar dependente, e o que acontece com seu corpo e seu humor nesses dias? , Quando a dor melhora, você sente que recupera interesse e presença, ou fica mais indiferente e distante mesmo com menos sofrimento físico?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- com fala arrastada ou dificuldade incomum de se manter desperto
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar se há efeito do tratamento
- piora clínica geral ou combinação com outras substâncias
- Quando há uso irregular
- redução por conta própria ou omissões frequentes por medo de dependência ou por efeitos incômodos
- pode valer comunicar o médico para prevenir piora da dor
- oscilação clínica e abandono silencioso
- Quando a analgesia parece insuficiente após um período de uso estável e a dor volta a dominar a sessão
- pode valer alinhar com o médico para reavaliar o quadro de base e o impacto funcional atual
- Quando surgem confusão nova
- desorientação
- quedas
- fala muito lentificada ou mudança cognitiva mais marcada do que o padrão habitual
- pode valer contato com o médico para esclarecer se há efeito medicamentoso
- intercorrência clínica ou agravamento da condição de base

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente mal consegue se manter acordado
- apresenta fala muito arrastada
- respiração visivelmente lenta ou rebaixamento importante do nível de consciência.: Interrompa o trabalho habitual e acione avaliação médica imediata; se houver risco clínico agudo
- contate emergência e rede de apoio no mesmo momento
- Surge confusão aguda
- desorientação
- comportamento muito incoerente ou piora abrupta do estado mental em comparação com a linha de base.: Trate como intercorrência clínica do dia
- busque suporte médico imediato e acione acompanhante ou rede de apoio conforme necessário

Frase clínica

Com morfina, o ponto central na terapia é distinguir alívio da dor de sedação, lentificação e uso irregular que reorganizam a sessão.

024 SULFATO DE MORFINA PENTAI DRATADO

Substância: Sulfato de Morfina Pentaidratado.

Nomes Comerciais: Dimorf Bolsa, Oppy, Dolo Moff

Uso comum

- Sulfato de morfina pentaidratado é um opioide usado sobretudo em dor moderada a intensa, muitas vezes em contextos de dor crônica, pós-operatório ou doença grave. No consultório de terapia, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como analgesia, sedação, lentificação, oscilação de atenção e relação com a dor reorganizam a sessão e a vida cotidiana. Mudanças subjetivas podem aparecer logo após início ou retomada, e também quando há uso irregular entre sessões. Vale acompanhar se o paciente chega mais sonolento, mais restrito afetivamente, mais centrado em dor e alívio, ou mais instável por flutuações entre sofrimento doloroso, efeito do remédio e impacto funcional.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e vigília:** Em parte dos pacientes, a sessão fica marcada por sonolência, fala mais lenta, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar elaboração mais complexa. Isso pode se confundir com exaustão pela própria dor, privação de sono, humor deprimido ou outras medicações com efeito sedativo. A discriminação clínica costuma depender de comparar o padrão atual com a baseline e de notar se a oscilação acompanha momentos de uso, piora da dor ou noites ruins.

Cognição e atenção: Pode haver lentificação cognitiva, lapsos atencionais, dificuldade de memória recente e menor capacidade de acompanhar encadeamentos emocionais mais longos. Na sessão, isso às vezes parece desinvestimento, resistência ou empobrecimento associativo, quando na verdade pode refletir dor intensa, efeito do tratamento, uso combinado de outras substâncias ou ambos. Vale observar se o paciente perde o fio apenas quando está mais sedado ou se a dificuldade persiste mesmo em momentos de maior alerta.

Humor e reatividade: O alívio parcial da dor pode melhorar irritabilidade e desesperança, mas também pode surgir embotamento, menor acesso afetivo ou oscilação entre apatia e maior reatividade quando a dor reaparece. Eventos de vida, luto pela perda de funcionalidade e frustração com limitações físicas frequentemente entram na mesma cena clínica e podem ser lidos apressadamente como efeito direto da medicação. O ponto útil é acompanhar se a mudança afetiva acompanha mais o nível de dor, o grau de sedação ou temas relacionais da sessão.

Adesão e uso irregular: Em opioides, uso irregular pode aparecer na terapia como alternância entre maior sofrimento, urgência por alívio, sonolência em alguns dias e piora global em outros, sem que o paciente nomeie isso espontaneamente. Também pode haver manejo autônomo do uso em função de medo de dependência, constipação, sonolência ou necessidade de funcionar no trabalho. Quando o padrão entre sessões fica muito variável, convém considerar não só evolução da dor e do quadro emocional, mas também flutuações de adesão.

Dor, funcionalidade e identidade: Como a morfina costuma entrar em cenários de dor importante, a sessão frequentemente se organiza em torno de limitação física, perda de autonomia, dependência de terceiros e estreitamento da vida psíquica ao redor do corpo. Isso pode reduzir disponibilidade para trabalho interpretativo e aumentar necessidade de manejo mais suportivo e focal. Nem toda retração, irritabilidade ou empobrecimento do vínculo decorre do medicamento; muitas vezes expressa o peso subjetivo de viver com dor persistente e tratamento contínuo."

O que observar em sessão

- **Sedação e vigília:** Em parte dos pacientes, a sessão fica marcada por sonolência, fala mais lenta, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar elaboração mais complexa. Isso pode se confundir com exaustão pela própria dor, privação de sono, humor deprimido ou outras medicações com efeito sedativo. A discriminação clínica costuma depender de comparar o padrão atual com a baseline e de notar se a oscilação acompanha momentos de uso, piora da dor ou noites ruins.

Cognição e atenção: Pode haver lentificação cognitiva, lapsos atencionais, dificuldade de memória recente e menor capacidade de acompanhar encadeamentos emocionais mais longos. Na sessão, isso às vezes parece desinvestimento, resistência ou empobrecimento associativo, quando na verdade pode refletir dor intensa, efeito do tratamento, uso combinado de outras substâncias ou ambos. Vale observar se o paciente perde o fio apenas quando está mais sedado ou se a dificuldade persiste mesmo em momentos de maior alerta.

Humor e reatividade: O alívio parcial da dor pode melhorar irritabilidade e desesperança, mas também pode surgir embotamento, menor acesso afetivo ou oscilação entre apatia e maior reatividade quando a dor reaparece. Eventos de vida, luto pela perda de funcionalidade e frustração com limitações físicas frequentemente entram na mesma cena clínica e podem ser lidos apressadamente como efeito direto da medicação. O ponto útil é acompanhar se a mudança afetiva acompanha mais o nível de dor, o grau de sedação ou temas relacionais da sessão.

Adesão e uso irregular: Em opioides, uso irregular pode aparecer na terapia como alternância entre maior sofrimento, urgência por alívio, sonolência em alguns dias e piora global em outros, sem que o paciente nomeie isso espontaneamente. Também pode haver manejo autônomo do uso em função de medo de dependência, constipação, sonolência ou necessidade de funcionar no trabalho. Quando o padrão entre sessões fica muito variável, convém considerar não só evolução da dor e do quadro emocional, mas também flutuações de adesão.

Dor, funcionalidade e identidade: Como a morfina costuma entrar em cenários de dor importante, a sessão frequentemente se organiza em torno de limitação física, perda de autonomia, dependência de terceiros e estreitamento da vida psíquica ao redor do corpo. Isso pode reduzir disponibilidade para trabalho interpretativo e aumentar necessidade de manejo mais suportivo e focal. Nem toda retração, irritabilidade ou empobrecimento do vínculo decorre do medicamento; muitas vezes expressa o peso subjetivo de viver com dor persistente e tratamento contínuo.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Sulfato de morfina pentaidratado é um opioide usado sobretudo em dor moderada a intensa, muitas vezes em contextos de dor crônica, pós-operatório ou doença grave. No consultório de terapia, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como analgesia, sedação, lentificação, oscilação de atenção e relação com a dor reorganizam a sessão e a vida cotidiana. Mudanças subjetivas podem aparecer logo após início ou retomada, e também quando há uso irregular entre sessões. Vale acompanhar se o paciente chega mais sonolento, mais restrito afetivamente, mais centrado em dor e alívio, ou mais instável por flutuações entre sofrimento doloroso, efeito do remédio e impacto funcional.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais apagado ou lento, isso costuma vir junto com alívio da dor, com noites ruins, ou aparece sem relação clara com nenhuma dessas coisas? , Nesses dias em que fica mais difícil pensar ou se concentrar, você percebe isso o tempo todo ou mais em certos períodos do dia? , Quando seu humor muda, a mudança parece acompanhar mais a intensidade da dor, o quanto você dormiu, ou alguma alteração no seu jeito de usar a medicação? , Você tem tido dias em que evita usar porque quer ficar mais desperto ou com medo de algum efeito, e depois acaba chegando à sessão em um estado bem diferente? , Esse distanciamento afetivo que aparece às vezes parece um alívio por estar sofrendo menos, ou uma sensação de estar meio desligado mesmo querendo se envolver?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- confuso ou com importante lentificação
- pode valer alinhar com o médico assistente para checar tolerabilidade e segurança funcional
- Quando surgem oscilações marcantes entre sessões associadas a uso irregular
- medo de usar ou manejo autônomo do medicamento
- pode valer comunicar o médico para esclarecer o padrão clínico e reduzir abandono silencioso
- Quando a analgesia parece insuficiente e a dor domina a sessão apesar do tratamento
- com queda importante de funcionalidade e humor
- pode valer contato com o médico para situar o impacto clínico atual
- Quando o paciente relata combinação com álcool ou outros sedativos e isso coincide com maior rebaixamento na sessão
- pode valer alinhamento com o médico pela relevância de segurança
- Quando aparecem constipação intensa
- náuseas persistentes ou outros efeitos que o paciente associa a vontade de interromper por conta própria
- pode valer comunicar o médico para prevenir descontinuidade não acompanhada

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente está muito difícil de despertar
- confuso
- com fala arrastada importante ou parece adormecer repetidamente em meio à conversa.: Interrompa o trabalho habitual e acione avaliação médica no mesmo dia; se houver rebaixamento importante do nível de consciência ou risco clínico imediato
- acione emergência e rede de apoio
- O paciente refere uso recente junto com álcool ou outros sedativos e chega com importante sonolência
- desorientação ou dificuldade de se manter acordado.: Trate como situação de risco agudo
- busque apoio imediato e acione avaliação médica no mesmo dia; considere emergência conforme o estado observado
- Surge ideação suicida com plano ou intenção em contexto de dor intensa
- desesperança e acesso a medicação potencialmente perigosa.: Faça manejo de risco imediatamente
- acione rede de apoio e avaliação urgente no mesmo dia
- incluindo emergência quando necessário

Frase clínica

Com morfina, o foco na terapia é distinguir analgesia, sedação e uso irregular do impacto psíquico de viver com dor importante.

025 MESILATO DE DI-HIDROERGOTAMINA;DIPIRONA MONOIDRATADA;CAFEÍNA

Substância: Mesilato de Di-Hidroergotamina;Dipirona Monoidratada;Cafeína.

Nomes Comerciais: Migraliv, Xaqueliv, Izenxaq

Uso comum

- Combinação usada em crises de cefaleia, sobretudo enxaqueca, e pouco frequente como foco principal no consultório de terapia. O que tende a aparecer em sessão não é um “efeito psíquico” específico da substância, mas o impacto do padrão de dor, do uso repetido em dias de crise e da oscilação funcional que acompanha o quadro. Vale situar temporalmente quando o paciente usa: apenas em crises isoladas, em vários dias da semana ou em sequência por semanas, porque isso ajuda a diferenciar sofrimento ligado à dor aguda, antecipação ansiosa de novas crises, sedação ou agitação associadas ao contexto de uso, e possível piora do padrão por automanejo irregular.

O paciente pode relatar

- **"Dor e sessão:** Quando a cefaleia está ativa ou muito próxima, o paciente pode chegar mais irritadiço, com menor tolerância a estímulos, dificuldade de sustentar elaboração e necessidade de encurtar a sessão. Isso pode ser confundido com resistência, retraimento afetivo ou piora primária do humor, quando às vezes o eixo organizador é a dor. Também vale observar se a oscilação coincide com dias de crise e se fora desse contexto a linha de base psíquica retorna ao padrão habitual.

Ansiedade antecipatória: Em parte dos pacientes, o sofrimento em sessão gira menos em torno da crise em si e mais do medo de uma nova dor, da necessidade de cancelar compromissos e da sensação de imprevisibilidade corporal. Esse estado pode se parecer com ansiedade generalizada ou hipervigilância basal, mas ganha outra leitura quando se organiza em torno de sinais corporais, agenda e evitação de gatilhos percebidos. A frequência recente das crises e o quanto a rotina passou a ser montada para evitar dor ajudam a discriminar.

Oscilação funcional: Pode surgir um padrão de funcionamento em sanfona: dias relativamente preservados alternados com dias de queda importante de produtividade, sociabilidade e disponibilidade psíquica. Na sessão, isso às vezes parece instabilidade emocional, quando parte da variação acompanha a presença de dor, náusea, fotossensibilidade ou cansaço pós-crise. Se o paciente usa a medicação em muitos episódios, a leitura clínica precisa incluir tanto a condição de base quanto o impacto do manejo das crises na rotina.

Uso repetido: Quando o paciente menciona recorrer ao medicamento com frequência crescente, a sessão pode trazer ambivalência entre alívio imediato e sensação de estar perdendo controle sobre o próprio corpo ou sobre a rotina. Isso pode ser confundido com dependência em sentido amplo ou com agravamento psiquiátrico, mas muitas vezes o dado central é o aumento do espaço que a cefaleia ocupa na vida psíquica. Vale observar se há uso silencioso, minimização da frequência real ou dificuldade de lembrar quantos dias da semana houve necessidade de tomar algo para a dor."

O que observar em sessão

- **Dor e sessão:** Quando a cefaleia está ativa ou muito próxima, o paciente pode chegar mais irritado, com menor tolerância a estímulos, dificuldade de sustentar elaboração e necessidade de encurtar a sessão. Isso pode ser confundido com resistência, retraimento afetivo ou piora primária do humor, quando às vezes o eixo organizador é a dor. Também vale observar se a oscilação coincide com dias de crise e se fora desse contexto a linha de base psíquica retorna ao padrão habitual.

Ansiedade antecipatória: Em parte dos pacientes, o sofrimento em sessão gira menos em torno da crise em si e mais do medo de uma nova dor, da necessidade de cancelar compromissos e da sensação de imprevisibilidade corporal. Esse estado pode se parecer com ansiedade generalizada ou hipervigilância basal, mas ganha outra leitura quando se organiza em torno de sinais corporais, agenda e evitação de gatilhos percebidos. A frequência recente das crises e o quanto a rotina passou a ser montada para evitar dor ajudam a discriminar.

Oscilação funcional: Pode surgir um padrão de funcionamento em sanfona: dias relativamente preservados alternados com dias de queda importante de produtividade, sociabilidade e disponibilidade psíquica. Na sessão, isso às vezes parece instabilidade emocional, quando parte da variação acompanha a presença de dor, náusea, fotossensibilidade ou cansaço pós-crise. Se o paciente usa a medicação em muitos episódios, a leitura clínica precisa incluir tanto a condição de base quanto o impacto do manejo das crises na rotina.

Uso repetido: Quando o paciente menciona recorrer ao medicamento com frequência crescente, a sessão pode trazer ambivalência entre alívio imediato e sensação de estar perdendo controle sobre o próprio corpo ou sobre a rotina. Isso pode ser confundido com dependência em sentido amplo ou com agravamento psiquiátrico, mas muitas vezes o dado central é o aumento do espaço que a cefaleia ocupa na vida psíquica. Vale observar se há uso silencioso, minimização da frequência real ou dificuldade de lembrar quantos dias da semana houve necessidade de tomar algo para a dor.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Combinação usada em crises de cefaleia, sobretudo enxaqueca, e pouco frequente como foco principal no consultório de terapia. O que tende a aparecer em sessão não é um “efeito psíquico” específico da substância, mas o impacto do padrão de dor, do uso repetido em dias de crise e da oscilação funcional que acompanha o quadro. Vale situar temporalmente quando o paciente usa: apenas em crises isoladas, em vários dias da semana ou em sequência por semanas, porque isso ajuda a diferenciar sofrimento ligado à dor aguda, antecipação ansiosa de novas crises, sedação ou agitação associadas ao contexto de uso, e possível piora do padrão por automanejo irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você fica mais fechado ou irritado na sessão, isso costuma acontecer junto com dor de cabeça naquele dia ou permanece igual mesmo em períodos sem crise? , Nos dias em que você usa esse remédio, o que muda primeiro para você: a dor, o ritmo do pensamento, o corpo mais acelerado ou mais cansado? , O medo de ter uma nova crise aparece só depois de episódios recentes de dor ou já fica presente mesmo em fases em que você está bem? , Quando sua semana desorganiza, isso vem principalmente pela intensidade da dor, pelos efeitos do dia de crise ou por você passar a evitar atividades com receio de piorar? , Você percebe que tem usado esse remédio em situações bem parecidas e previsíveis ou o uso foi se espalhando para mais dias e contextos do que antes?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente relata uso em muitos dias da semana ou aumento progressivo da frequência
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar o padrão de crises e o manejo atual
- Quando a dor passa a reorganizar a rotina
- com faltas frequentes
- cancelamentos e retração social persistente
- pode valer comunicar o médico para situar a perda funcional associada ao quadro
- Quando o paciente descreve mal-estar importante após usar a medicação
- com impacto recorrente na sessão e risco de abandono silencioso
- pode valer alinhar com o médico para qualificar tolerabilidade e adesão real
- Quando surgem palpitações
- agitação corporal marcante ou piora importante do sono em proximidade consistente com o uso
- pode valer comunicar o médico para diferenciar efeito do contexto de crise e outras causas clínicas

Vermelho: tratar como urgência

- Durante ou após o uso
- o paciente chega à sessão com dor no peito
- falta de ar
- desmaio
- confusão importante ou mal-estar físico intenso e incomum.: Interromper o enquadre habitual e acionar avaliação médica no mesmo dia
- com rede de apoio e emergência quando necessário
- A sessão ocorre em contexto de cefaleia muito intensa e diferente do padrão habitual
- especialmente se acompanhada de fala enrolada

Vermelho: tratar como urgência

- fraqueza
- desorientação ou alteração visual persistente.: Tratar como situação de urgência clínica e encaminhar para avaliação médica imediata

Frase clínica

Nesta combinação, o foco terapêutico costuma ser menos o fármaco e mais como dor, uso repetido e antecipação ansiosa reorganizam a vida psíquica.

026 GABAPENTINA

Substância: Gabapentina.

Nomes Comerciais: Gabapentina, Empak, Gapem, Gabaneurin

Uso comum

- Gabapentina é um anticonvulsivante também usado em dor neuropática e, em alguns contextos, pode aparecer em pacientes acompanhados por ansiedade, insônia ou queixas somáticas dolorosas. No consultório, costuma importar menos a indicação formal e mais como o paciente chega: mais sonolento, mais lento, menos reativo ou, às vezes, com alívio parcial da dor e melhora do sono. Mudanças perceptíveis podem surgir nos primeiros dias a 1-2 semanas após início ou retomada, e oscilações também podem acompanhar uso irregular. O ponto central na sessão é diferenciar sedação e lentificação de melhora clínica genuína, além de notar quando efeitos incômodos favorecem adesão errática.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Sonolência, fala mais arrastada, redução do ritmo associativo e menor prontidão podem aparecer já no início ou após mudanças recentes no uso. Em sessão, isso pode se confundir com retraimento depressivo, exaustão por dor crônica, privação de sono ou efeito de outras medicações sedativas em conjunto. Vale observar se a lentificação é mais corporal e atencional do que afetiva, e se o paciente descreve piora em horários específicos ou após retomar o medicamento depois de falhas no uso.

Cognição: Alguns pacientes chegam mais esquecidos, com dificuldade de sustentar o fio da conversa ou de acessar palavras com a fluidez habitual. Isso pode ser lido apressadamente como piora ansiosa, sobrecarga emocional, impacto da dor persistente ou efeito do próprio quadro de base. A discriminação clínica melhora quando se compara a baseline da sessão com o momento de início do tratamento, comorbidades e presença de oscilação conforme o horário ou a regularidade do uso.

Sono e energia: Pode haver melhora do adormecer e do sono fragmentado, mas também sensação de ressaca, menor disposição matinal ou queda de energia ao longo do dia. Na psicoterapia, isso às vezes parece melhora da ansiedade quando na verdade há apenas redução global da ativação, ou parece agravamento depressivo quando o sono noturno melhorou e o problema central passou a ser sedação residual. Eventos de vida, dor noturna e uso concomitante de álcool ou hipnóticos podem embaralhar essa leitura.

Dor e funcionalidade: Quando a gabapentina está sendo usada por dor neuropática ou desconfortos corporais persistentes, o efeito subjetivo mais relevante na sessão pode ser menos sofrimento físico, mais tolerância à rotina ou, ao contrário, frustração por alívio insuficiente. Mudanças no humor e na irritabilidade podem acompanhar a oscilação da dor sem que isso signifique efeito psíquico direto do medicamento. Vale acompanhar se a sessão fica menos capturada pela dor e mais disponível para elaboração, ou se a lentificação passou a limitar a funcionalidade apesar de algum alívio corporal.

Adesão irregular: Uso intermitente, esquecimentos e retomadas sem regularidade podem produzir um padrão confuso: dias de maior sonolência, dias de pior sono, retorno da dor ou sensação de que o medicamento 'ora ajuda, ora atrapalha'. No consultório, isso pode ser confundido com instabilidade emocional, resistência ao tratamento ou flutuação espontânea do quadro. A pista clínica costuma estar menos no conteúdo da queixa e mais na inconsistência temporal entre o que o paciente relata e o padrão habitual das sessões."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Sonolência, fala mais arrastada, redução do ritmo associativo e menor prontidão podem aparecer já no início ou após mudanças recentes no uso. Em sessão, isso pode se confundir com retraimento depressivo, exaustão por dor crônica, privação de sono ou efeito de outras medicações sedativas em conjunto. Vale observar se a lentificação é mais corporal e atencional do que afetiva, e se o paciente descreve piora em horários específicos ou após retomar o medicamento depois de falhas no uso.

Cognição: Alguns pacientes chegam mais esquecidos, com dificuldade de sustentar o fio da conversa ou de acessar palavras com a fluidez habitual. Isso pode ser lido apressadamente como piora ansiosa, sobrecarga emocional, impacto da dor persistente ou efeito do próprio quadro de base. A discriminação clínica melhora quando se compara a baseline da sessão com o momento de início do tratamento, comorbidades e presença de oscilação conforme o horário ou a regularidade do uso.

Sono e energia: Pode haver melhora do adormecer e do sono fragmentado, mas também sensação de ressaca, menor disposição matinal ou queda de energia ao longo do dia. Na psicoterapia, isso às vezes parece melhora da ansiedade quando na verdade há apenas redução global da ativação, ou parece agravamento depressivo quando o sono noturno melhorou e o problema central passou a ser sedação residual. Eventos de vida, dor noturna e uso concomitante de álcool ou hipnóticos podem embaralhar essa leitura.

Dor e funcionalidade: Quando a gabapentina está sendo usada por dor neuropática ou desconfortos corporais persistentes, o efeito subjetivo mais relevante na sessão pode ser menos sofrimento físico, mais tolerância à rotina ou, ao contrário, frustração por alívio insuficiente. Mudanças no humor e na irritabilidade podem acompanhar a oscilação da dor sem que isso signifique efeito psíquico direto do medicamento. Vale acompanhar se a sessão fica menos capturada pela dor e mais disponível para elaboração, ou se a lentificação passou a limitar a funcionalidade apesar de algum alívio corporal.

Adesão irregular: Uso intermitente, esquecimentos e retomadas sem regularidade podem produzir um padrão confuso: dias de maior sonolência, dias de pior sono, retorno da dor ou sensação de que o medicamento 'ora ajuda, ora atrapalha'. No consultório, isso pode ser confundido com instabilidade emocional, resistência ao tratamento ou flutuação espontânea do quadro. A pista clínica costuma estar menos no conteúdo da queixa e mais na inconsistência temporal entre o que o paciente relata e o padrão habitual das sessões.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Gabapentina é um anticonvulsivante também usado em dor neuropática e, em alguns contextos, pode aparecer em pacientes acompanhados por ansiedade, insônia ou queixas somáticas dolorosas. No consultório, costuma importar menos a indicação formal e mais como o paciente chega: mais sonolento, mais lento, menos reativo ou, às vezes, com alívio parcial da dor e melhora do sono. Mudanças perceptíveis podem surgir nos primeiros dias a 1-2 semanas após início ou retomada, e oscilações também podem acompanhar uso irregular. O ponto central na sessão é diferenciar sedação e lentificação de melhora clínica genuína, além de notar quando efeitos incômodos favorecem adesão errática.

Perguntas úteis

- "Quando você se percebe mais lento ou sonolento, isso vem junto de sensação de tristeza e desesperança ou parece mais um corpo e uma cabeça funcionando em marcha reduzida? , Nos dias em que você dorme melhor, você acorda mais restaurado ou sente como se estivesse carregando uma ressaca ao longo da manhã? , Essa dificuldade de concentração aparece mesmo quando a dor e a ansiedade estão mais baixas, ou ela piora principalmente nos dias em que você está mais sobrecarregado ou com mais dor? , Quando você diz que o remédio às vezes ajuda e às vezes atrapalha, isso acompanha algum padrão de horário, esquecimentos ou retomadas depois de alguns dias sem usar? , A redução da sua reatividade tem sido vivida como alívio com mais espaço para pensar, ou como um apagamento que atrapalha presença, trabalho e vínculo?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- lentificado ou cognitivamente embotado a ponto de prejudicar trabalho
- direção ou manejo da rotina
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar a relevância clínica desse impacto funcional
- Quando há relato de uso irregular
- esquecimentos frequentes ou retomadas intermitentes acompanhadas de oscilação importante de sono
- dor ou disposição
- pode valer comunicar o médico para contextualizar a leitura da resposta clínica
- Quando a dor permanece ocupando grande parte da sessão após algumas semanas de uso
- sem mudança subjetiva perceptível ou com frustração crescente
- pode valer alinhar com o médico para situar ausência de benefício percebido
- Quando surgem tontura
- instabilidade ou quedas associadas à sonolência observada em sessão
- pode valer contato com o médico pela repercussão funcional e risco de acidentes

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- o paciente apresenta rebaixamento importante do nível de alerta
- fala muito desconexa
- dificuldade de se manter acordado ou de se locomover com segurança.: Interromper o trabalho interpretativo
- avaliar segurança imediata

Vermelho: tratar como urgência

- acionar acompanhante ou rede de apoio se necessário e buscar contato médico no mesmo dia; considerar emergência se houver risco clínico evidente
- Surge ideação suicida atual com intenção
- plano ou perda de controle
- independentemente de a gabapentina parecer ou não relacionada ao momento.: Fazer manejo de crise no próprio setting
- acionar rede de apoio e avaliação urgente no mesmo dia conforme o risco

Frase clínica

O foco é distinguir alívio de dor e redução de ativação de uma sedação que empobrece presença, cognição e adesão.

027 PREGABALINA

Substância: Pregabalina.

Nomes Comerciais: Jolik, Pregabalina, Limiar, Mobale, Insit, Insit®, Konduz, Glya, Ápice, Prefiss, Pregalpha, Zeropin, Infoc, Dorene, Dorene Tabs, Dorene Líquido, Prebictal, Lycerah, Proleptol, Lyrica

Uso comum

- Pregabalina é um modulador neurológico usado sobretudo em dor neuropática, fibromialgia, ansiedade generalizada e, em alguns contextos, como adjuvante em epilepsia. No consultório, costuma aparecer mais pela combinação entre redução de tensão/hipervigilância e efeitos de lentificação, sonolência ou sensação de “cabeça estranha”, especialmente nos primeiros dias e nas primeiras 1 a 2 semanas após início ou mudança recente no uso. Quando há benefício, parte dos pacientes nota menos ansiedade somática e melhor sono ao longo das primeiras semanas. O ponto central na sessão é diferenciar alívio clínico de sedação, além de rastrear uso irregular, já que interrupções ou tomadas inconsistentes podem produzir oscilação subjetiva importante.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento: fala menos espontânea, maior latência para responder, bocejos, aparência de sonolência ou menor iniciativa associativa. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento no processo ou resistência, quando às vezes coincide temporalmente com início recente do medicamento ou com uso em horários que repercutem no período da sessão. Também vale considerar privação de sono, dor crônica exaustiva e outras medicações sedativas como explicações concorrentes.

Ansiedade somática: Quando a pregabalina ajuda, pode haver redução de tensão corporal, sobressalto, inquietação física e urgência autonômica, com o paciente parecendo menos tomado pelo corpo e mais disponível para elaborar. Ainda assim, uma queda da reatividade somática não equivale necessariamente a melhora global do quadro: preocupações centrais, evitação e ruminação podem permanecer quase intactas. Se a ansiedade oscila muito entre sessões, vale suspeitar de adesão irregular, eventos de vida recentes ou uso concomitante de substâncias, e não atribuir a mudança ao medicamento de forma automática.

Cognição e clareza: Alguns pacientes descrevem cabeça pesada, dificuldade de concentração, sensação de estar mais lento ou menos nítido, o que pode aparecer na sessão como perda do fio, menor memória de detalhes e elaboração mais concreta. Esse padrão pode se confundir com fadiga, sobrecarga por dor persistente, ansiedade alta ou efeito residual de noites mal dormidas. A pista clínica costuma estar na relação temporal entre a mudança subjetiva e o início do uso, além da discrepância entre sofrimento emocional estável e queda recente de clareza mental.

Dor e funcionalidade: Como muitos chegam à pregabalina por dor crônica ou desconforto corporal persistente, mudanças no humor e na disponibilidade psíquica podem acompanhar variações da dor mais do que um efeito emocional direto do medicamento. Quando a dor cede, o paciente pode retomar atividades, dormir melhor e parecer mais esperançoso; quando não cede, frustração e irritabilidade podem dominar a sessão apesar de adesão adequada. Vale observar se a narrativa muda porque o sofrimento físico diminuiu, porque houve melhora ansiosa, ou porque a expectativa de alívio foi frustrada.

Adesão e interrupção: Uso irregular é clinicamente relevante porque pode produzir dias muito diferentes entre si: em uma sessão o paciente chega mais sedado, em outra mais tenso, irritado ou com sono ruim, sem que isso represente necessariamente instabilidade do quadro de base. Às vezes a irregularidade não aparece como "não adesão", mas como esquecimento, ajuste por conta própria para lidar com sonolência ou uso apenas em momentos de maior desconforto. Quando o padrão da sessão muda abruptamente, vale explorar a sequência concreta dos últimos dias antes de concluir recaída, resistência ou piora estrutural."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento: fala menos espontânea, maior latência para responder, bocejos, aparência de sonolência ou menor iniciativa associativa. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento no processo ou resistência, quando às vezes coincide temporalmente com início recente do medicamento ou com uso em horários que repercutem no período da sessão. Também vale considerar privação de sono, dor crônica exaustiva e outras medicações sedativas como explicações concorrentes.

Ansiedade somática: Quando a pregabalina ajuda, pode haver redução de tensão corporal, sobressalto, inquietação física e urgência autonômica, com o paciente parecendo menos tomado pelo corpo e mais disponível para elaborar. Ainda assim, uma queda da reatividade somática não equivale necessariamente a melhora global do quadro: preocupações centrais, evitação e ruminação podem permanecer quase intactas. Se a ansiedade oscila muito entre sessões, vale suspeitar de adesão irregular, eventos de vida recentes ou uso concomitante de substâncias, e não atribuir a mudança ao medicamento de forma automática.

Cognição e clareza: Alguns pacientes descrevem cabeça pesada, dificuldade de concentração, sensação de estar mais lento ou menos nítido, o que pode aparecer na sessão como perda do fio, menor memória de detalhes e elaboração mais concreta. Esse padrão pode se confundir com fadiga, sobrecarga por dor persistente, ansiedade alta ou efeito residual de noites mal dormidas. A pista clínica costuma estar na relação temporal entre a mudança subjetiva e o início do uso, além da discrepância entre sofrimento emocional estável e queda recente de clareza mental.

Dor e funcionalidade: Como muitos chegam à pregabalina por dor crônica ou desconforto corporal persistente, mudanças no humor e na disponibilidade psíquica podem acompanhar variações da dor mais do que um efeito emocional direto do medicamento. Quando a dor cede, o paciente pode retomar atividades, dormir melhor e parecer mais esperançoso; quando não cede, frustração e irritabilidade podem dominar a sessão apesar de adesão adequada. Vale observar se a narrativa muda porque o sofrimento físico diminuiu, porque houve melhora ansiosa, ou porque a expectativa de alívio foi frustrada.

Adesão e interrupção: Uso irregular é clinicamente relevante porque pode produzir dias muito diferentes entre si: em uma sessão o paciente chega mais sedado, em outra mais tenso, irritado ou com sono ruim, sem que isso represente necessariamente instabilidade do quadro de base. Às vezes a irregularidade não aparece como “não adesão”, mas como esquecimento, ajuste por conta própria para lidar com sonolência ou uso apenas em momentos de maior desconforto. Quando o padrão da sessão muda abruptamente, vale explorar a sequência concreta dos últimos dias antes de concluir recaída, resistência ou piora estrutural.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Pregabalina é um modulador neurológico usado sobretudo em dor neuropática, fibromialgia, ansiedade generalizada e, em alguns contextos, como adjuvante em epilepsia. No consultório, costuma aparecer mais pela combinação entre redução de tensão/hipervigilância e efeitos de lentificação, sonolência ou sensação de “cabeça estranha”, especialmente nos primeiros dias e nas primeiras 1 a 2 semanas após início ou mudança recente no uso. Quando há benefício, parte dos pacientes nota menos ansiedade somática e melhor sono ao longo das primeiras semanas. O ponto central na sessão é diferenciar alívio clínico de sedação, além de rastrear uso irregular, já que interrupções ou tomadas inconsistentes podem produzir oscilação subjetiva importante.

Perguntas úteis

- "Essa lentidão que você percebe vem junto de sono e corpo mais pesado, ou você sente tristeza e desânimo mesmo estando desperto? , Quando você diz que está menos ansioso, isso aparece mais como menos tensão no corpo ou também como menos preocupação, menos evitação e mais liberdade para fazer as coisas? , Nos dias em que sua cabeça parece mais lenta, isso começou depois de alguma mudança recente no uso ou acontece do mesmo jeito mesmo quando sua rotina e seu sono estão parecidos? , Quando sua semana oscila muito, essas mudanças acompanham mais a intensidade da dor, acontecimentos do dia a dia ou dias em que o uso saiu do padrão? , Esse afastamento das atividades vem porque você está sem vontade e sem esperança, ou porque está mais sonolento, tonto ou sem clareza para se organizar? , Quando você ficou pior, isso pareceu uma volta do problema de antes ou uma mudança mais brusca, em poucos dias, depois de ter saído do seu padrão de uso?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- lentificado ou cognitivamente embotado a ponto de prejudicar trabalho
- direção ou o próprio processo terapêutico
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisão clínica da tolerabilidade
- Quando há uso irregular
- interrupções frequentes ou manejo por conta própria para evitar sonolência
- pode valer comunicar o médico assistente porque esse padrão pode confundir a leitura da resposta clínica e favorecer oscilação subjetiva
- Quando a ansiedade corporal melhora
- mas persiste sofrimento psíquico importante
- evitação marcada ou prejuízo funcional após algumas semanas
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a resposta parcial observada em sessão
- Quando surgem tontura
- instabilidade ou quedas relatadas junto de sedação importante

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicação com o médico assistente pela repercussão funcional e risco no cotidiano
- Quando aparece piora importante do humor
- irritabilidade incomum ou ideação suicida em proximidade temporal com início recente ou mudança no uso
- pode valer contato com o médico assistente para avaliação clínica mais rápida

Vermelho: tratar como urgência

- Surge ideação suicida nova ou claramente intensificada
- sobretudo quando acompanhada de piora rápida do humor
- agitação ou sensação de desorganização após mudança recente no uso.: Fazer avaliação de risco na hora e acionar no mesmo dia o médico assistente
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente relata confusão importante
- muita instabilidade para andar
- quedas
- fala muito enrolada ou rebaixamento acentuado do estado de alerta.: Interromper o foco interpretativo da sessão e encaminhar para avaliação médica imediata
- com apoio de acompanhante ou serviço de urgência se preciso

Frase clínica

O foco é distinguir alívio de ansiedade e dor de sedação, lentificação e oscilação ligada a uso irregular.

028 VIGABATRINA

Substância: Vigabatrina.

Nomes Comerciais: Sabril

Uso comum

- Vigabatrina é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsias de difícil controle e, em alguns contextos, em espasmos infantis. No consultório de terapia, tende a aparecer mais como parte de um tratamento neurológico contínuo do que como foco principal da sessão. Mudanças subjetivas podem surgir nas primeiras semanas após início ou ajuste, mas a leitura clínica costuma exigir cautela porque sono, atenção, irritabilidade e oscilação de humor também variam com a própria epilepsia, com o impacto das crises e com outras medicações em uso. O ponto central é acompanhar alterações de funcionamento, comportamento e vínculo com o tratamento sem atribuição causal apressada.

O paciente pode relatar

- **"Humor e irritabilidade:** Alguns pacientes podem chegar mais irritáveis, com menor tolerância à frustração, labilidade emocional ou sensação de estranhamento subjetivo desde mudanças recentes no tratamento. Na sessão, isso pode aparecer como reatividade aumentada, impaciência, menor capacidade de elaboração ou um tom mais brusco do que a linha de base habitual. A leitura pede cuidado porque privação de sono, medo de novas crises, sobrecarga familiar e a própria epilepsia também podem produzir quadro semelhante, além de adesão irregular ou uso concomitante de outros anticonvulsivantes.

Cognição e atenção: Lentificação, dificuldade de concentração, falhas de memória recente ou maior esforço para acompanhar a conversa podem se tornar mais visíveis no setting terapêutico. O terapeuta pode notar perda do fio narrativo, necessidade de repetição e menor sustentação atencional, sobretudo em comparação com sessões anteriores. Isso pode se confundir com fadiga pós-crise, ansiedade, humor deprimido, efeitos cumulativos de polifarmácia ou impacto funcional da doença crônica, de modo que vale ancorar a observação em mudanças concretas de baseline.

Sono e energia: Sonolência, cansaço diurno ou redução de energia podem aparecer como menor vivacidade, fala mais lenta e dificuldade de engajamento na sessão. Em alguns casos, o paciente descreve que está mais apagado; em outros, a fadiga parece acompanhar períodos de maior frequência de crises ou noites fragmentadas. A distinção clínica importante é entre sedação possivelmente relacionada ao tratamento, exaustão pela condição de base e retraimento depressivo, especialmente quando houve mudança recente no padrão de funcionamento.

Visão e funcionalidade: Como se trata de um medicamento associado a preocupação oftalmológica relevante, alterações visuais merecem escuta específica quando o paciente menciona esbarrões, insegurança para circular, dificuldade para ler ou sensação de que o campo visual está diferente. Na sessão, isso pode surgir indiretamente como redução de autonomia, evitação de sair sozinho e aumento de dependência de familiares. Nem toda queixa visual se relaciona ao medicamento, mas mudanças persistentes na funcionalidade visual têm valor clínico suficiente para não serem tratadas apenas como ansiedade ou distração.

Carga do tratamento: Em muitos casos, o aspecto mais saliente não é um efeito subjetivo isolado, mas o peso de viver com epilepsia de difícil controle, exames, vigilância familiar e medo de crises. Isso pode reorganizar identidade, autonomia, escolaridade, trabalho e vida social, aparecendo na sessão como hipervigilância corporal, vergonha, sensação de futuro encurtado ou relação ambivalente com o tratamento. Também aqui a adesão pode oscilar silenciosamente, não só por tolerabilidade, mas por cansaço de tratamento, negação da gravidade ou desejo de retomar uma vida menos medicalizada."

O que observar em sessão

- **Humor e irritabilidade:** Alguns pacientes podem chegar mais irritáveis, com menor tolerância à frustração, labilidade emocional ou sensação de estranhamento subjetivo desde mudanças recentes no tratamento. Na sessão, isso pode aparecer como reatividade aumentada, impaciência, menor capacidade de elaboração ou um tom mais brusco do que a linha de base habitual. A leitura pede cuidado porque privação de sono, medo de novas crises, sobrecarga familiar e a própria epilepsia também podem produzir quadro semelhante, além de adesão irregular ou uso concomitante de outros anticonvulsivantes.

Cognição e atenção: Lentificação, dificuldade de concentração, falhas de memória recente ou maior esforço para acompanhar a conversa podem se tornar mais visíveis no setting terapêutico. O terapeuta pode notar perda do fio narrativo, necessidade de repetição e menor sustentação atencional, sobretudo em comparação com sessões anteriores. Isso pode se confundir com fadiga pós-crise, ansiedade, humor deprimido, efeitos cumulativos de polifarmácia ou impacto funcional da doença crônica, de modo que vale ancorar a observação em mudanças concretas de baseline.

Sono e energia: Sonolência, cansaço diurno ou redução de energia podem aparecer como menor vivacidade, fala mais lenta e dificuldade de engajamento na sessão. Em alguns casos, o paciente descreve que está mais apagado; em outros, a fadiga parece acompanhar períodos de maior frequência de crises ou noites fragmentadas. A distinção clínica importante é entre sedação possivelmente relacionada ao tratamento, exaustão pela condição de base e retraimento depressivo, especialmente quando houve mudança recente no padrão de funcionamento.

Visão e funcionalidade: Como se trata de um medicamento associado a preocupação oftalmológica relevante, alterações visuais merecem escuta específica quando o paciente menciona esbarrões, insegurança para circular, dificuldade para ler ou sensação de que o campo visual está diferente. Na sessão, isso pode surgir indiretamente como redução de autonomia, evitação de sair sozinho e aumento de dependência de familiares. Nem toda queixa visual se relaciona ao medicamento, mas mudanças persistentes na funcionalidade visual têm valor clínico suficiente para não serem tratadas apenas como ansiedade ou distração.

Carga do tratamento: Em muitos casos, o aspecto mais saliente não é um efeito subjetivo isolado, mas o peso de viver com epilepsia de difícil controle, exames, vigilância familiar e medo de crises. Isso pode reorganizar identidade, autonomia, escolaridade, trabalho e vida social, aparecendo na sessão como hipervigilância corporal, vergonha, sensação de futuro encurtado ou relação ambivalente com o tratamento. Também aqui a adesão pode oscilar silenciosamente, não só por tolerabilidade, mas por cansaço de tratamento, negação da gravidade ou desejo de retomar uma vida menos medicalizada.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Vigabatrina é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsias de difícil controle e, em alguns contextos, em espasmos infantis. No consultório de terapia, tende a aparecer mais como parte de um tratamento neurológico contínuo do que como foco principal da sessão. Mudanças subjetivas podem surgir nas primeiras semanas após início ou ajuste, mas a leitura clínica costuma exigir cautela porque sono, atenção, irritabilidade e oscilação de humor também variam com a própria epilepsia, com o impacto das crises e com outras medicações em uso. O ponto central é acompanhar alterações de funcionamento, comportamento e vínculo com o tratamento sem atribuição causal apressada.

Perguntas úteis

- "Essas mudanças de irritação ou estranhamento começaram depois de alguma mudança recente no tratamento, ou você já se reconhecia assim antes desse período? , Quando você se sente mais lento ou disperso, isso acontece de modo mais constante ao longo dos dias ou aparece mais depois de crises, noites ruins ou momentos de maior ansiedade? , Esse cansaço vem com sono e sensação de corpo pesado, ou parece mais uma perda de interesse e iniciativa para as coisas? , Quando você fala que está enxergando pior, percebe mais dificuldade para ler e focar ou mais esbarrões e insegurança com o que está ao redor? , Nos dias em que você evita ou atrasa o remédio, o que muda mais: seu humor, sua disposição, sua sensação de controle ou seu medo das crises?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve mudança visual persistente
- com impacto em leitura
- locomoção ou autonomia
- pode valer alinhar com o médico assistente para checar a relevância clínica dessa alteração
- Quando surgem irritabilidade
- rebaixamento do humor ou mudança comportamental nítida após início recente ou mudança no tratamento
- pode valer comunicar para ajudar na diferenciação entre efeito do tratamento
- evolução neurológica e fatores contextuais
- Quando a lentificação
- sonolência ou dificuldade cognitiva passam a comprometer trabalho
- estudo ou participação na própria psicoterapia
- pode valer contato com o médico para situar o prejuízo funcional observado
- Quando o paciente admite adesão irregular
- interrupções por conta própria ou uso muito inconsistente por cansaço do tratamento
- pode valer alinhar com o médico assistente porque isso dificulta a leitura clínica e pode aumentar vulnerabilidade
- Quando familiares ou cuidadores relatam mudança importante de comportamento

Amarelo: alinhar em breve

- retraimento incomum ou piora global do funcionamento em paralelo ao tratamento
- pode valer comunicação para integrar observações de diferentes contextos

Vermelho: tratar como urgência

- A sessão revela ideação suicida emergente ou intensificada
- sobretudo quando acompanhada de piora recente do humor
- desesperança ou mudança comportamental marcante.: Fazer avaliação de risco no mesmo encontro e acionar no mesmo dia psiquiatra ou médico assistente
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente chega muito confuso
- desorganizado
- intensamente agitado ou com rebaixamento importante do nível de responsividade em comparação com seu padrão habitual.: Interromper a leitura psicoterápica usual e buscar avaliação médica no mesmo dia
- com apoio de familiar ou serviço de urgência conforme a gravidade

Frase clínica

Com vigabatrina, o foco terapêutico costuma ser distinguir efeito subjetivo, impacto da epilepsia e carga do tratamento contínuo.

029 CARBAMAZEPINA

Substância: Carbamazepina.

Nomes Comerciais: Carbamazepina, Tegretol, Tegretard, Uni-Carbamaz, Tegrezin

Uso comum

- Carbamazepina é um anticonvulsivante que também pode aparecer no consultório em pacientes com transtorno bipolar, dor neuropática e alguns quadros neurológicos. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta costuma acompanhar mais de perto sedação, lentificação, tontura, instabilidade subjetiva e impacto funcional, que podem confundir a leitura do humor e da motivação. Ao longo de algumas semanas, vale observar se há estabilização do padrão da sessão ou se persistem oscilação, adesão irregular e queixas físicas que alteram presença, cognição e vínculo. O ponto central é diferenciar efeito de início ou de retomada, flutuação do quadro de base e uso inconsistente.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** No início ou após mudanças recentes no uso, o paciente pode chegar mais sonolento, lento para associar ideias ou com menor iniciativa verbal. Em sessão, isso pode parecer retraimento depressivo, desinvestimento no processo ou baixa capacidade de elaboração, quando às vezes o eixo principal é redução do estado de alerta. Também vale considerar privação de sono, outras medicações sedativas e uso irregular, sobretudo quando a identificação varia muito de um encontro para outro.

Cognição funcional: Alguns pacientes descrevem dificuldade para encontrar palavras, manter o fio da conversa ou sustentar atenção em tarefas habituais. Na sessão, isso pode aparecer como discurso mais truncado, necessidade de retomadas frequentes e menor complexidade associativa, o que pode ser confundido com piora depressiva, ansiedade elevada ou sobrecarga de vida. A comparação com a linha de base e com o momento de início do tratamento ajuda mais do que interpretar isoladamente a queda de rendimento.

Humor e reatividade: Quando usada em contexto de instabilidade do humor, a carbamazepina pode coincidir com redução de impulsividade e reatividade, mas também com sensação subjetiva de achatamento ou estranhamento de si. Em sessão, o desafio é distinguir maior estabilidade de um embotamento vivido como perda de vivacidade, e ambos de uma fase depressiva em instalação. Eventos interpessoais recentes, padrão prévio de oscilação e adesão irregular podem mudar bastante essa leitura.

Adesão e oscilação: Por ser um tratamento que pode trazer efeitos perceptíveis no corpo e na atenção, há pacientes que passam a tomar de modo irregular sem comunicar espontaneamente. O terapeuta pode notar alternância entre sessões com maior clareza e outras com mais lentificação, tontura, irritabilidade ou piora do sono, o que às vezes parece instabilidade emocional primária. Quando o padrão fica serrilhado, vale explorar a sequência temporal entre uso, rotina e mudanças subjetivas antes de concluir recaída ou resistência ao tratamento.

Sinais físicos na sessão: Tontura, sensação de desequilíbrio, visão turva referida pelo paciente, náusea e mal-estar inespecífico podem atravessar a sessão e reduzir tolerância a esforço cognitivo e emocional. Esses elementos podem ser lidos apressadamente como ansiedade somatizada, crise de pânico ou evitação, especialmente se surgem em momentos de maior mobilização afetiva. A observação clínica ganha precisão quando se nota se o desconforto acompanha o encontro inteiro, aparece ao levantar, ou varia conforme o dia e a regularidade do uso.

Pele e mal-estar: Embora não seja o mais frequente no consultório de terapia, o aparecimento de manchas, vermelhidão, coceira importante ou sensação de adoecimento geral merece atenção porque pode surgir junto de queda abrupta de presença e aumento de preocupação corporal. Em sessão, isso pode vir como queixa secundária, minimizada pelo paciente, enquanto o terapeuta percebe piora global do engajamento e do bem-estar. Aqui, o risco é tratar como estresse inespecífico algo que pede checagem médica mais breve."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** No início ou após mudanças recentes no uso, o paciente pode chegar mais sonolento, lento para associar ideias ou com menor iniciativa verbal. Em sessão, isso pode parecer retraimento depressivo, desinvestimento no processo ou baixa capacidade de elaboração, quando às vezes o eixo principal é redução do estado de alerta. Também vale considerar privação de sono, outras medicações sedativas e uso irregular, sobretudo quando a identificação varia muito de um encontro para outro.

Cognição funcional: Alguns pacientes descrevem dificuldade para encontrar palavras, manter o fio da conversa ou sustentar atenção em tarefas habituais. Na sessão, isso pode aparecer como discurso mais truncado, necessidade de retomadas frequentes e menor complexidade associativa, o que pode ser confundido com piora depressiva, ansiedade elevada ou sobrecarga de vida. A comparação com a linha de base e com o momento de início do tratamento ajuda mais do que interpretar isoladamente a queda de rendimento.

Humor e reatividade: Quando usada em contexto de instabilidade do humor, a carbamazepina pode coincidir com redução de impulsividade e reatividade, mas também com sensação subjetiva de achatamento ou estranhamento de si. Em sessão, o desafio é distinguir maior estabilidade de um embotamento vivido como perda de vivacidade, e ambos de uma fase depressiva em instalação. Eventos interpessoais recentes, padrão prévio de oscilação e adesão irregular podem mudar bastante essa leitura.

Adesão e oscilação: Por ser um tratamento que pode trazer efeitos perceptíveis no corpo e na atenção, há pacientes que passam a tomar de modo irregular sem comunicar espontaneamente. O terapeuta pode notar alternância entre sessões com maior clareza e outras com mais lentificação, tontura, irritabilidade ou piora do sono, o que às vezes parece instabilidade emocional primária. Quando o padrão fica serrilhado, vale explorar a sequência temporal entre uso, rotina e mudanças subjetivas antes de concluir recaída ou resistência ao tratamento.

Sinais físicos na sessão: Tontura, sensação de desequilíbrio, visão turva referida pelo paciente, náusea e mal-estar inespecífico podem atravessar a sessão e reduzir tolerância a esforço cognitivo e emocional. Esses elementos podem ser lidos apressadamente como ansiedade somatizada, crise de pânico ou evitação, especialmente se surgem em momentos de maior mobilização afetiva. A observação clínica ganha precisão quando se nota se o desconforto acompanha o encontro inteiro, aparece ao levantar, ou varia conforme o dia e a regularidade do uso.

Pele e mal-estar: Embora não seja o mais frequente no consultório de terapia, o aparecimento de manchas, vermelhidão, coceira importante ou sensação de adoecimento geral merece atenção porque pode surgir junto de queda abrupta de presença e aumento de preocupação corporal. Em sessão, isso pode vir como queixa secundária, minimizada pelo paciente, enquanto o terapeuta percebe piora global do engajamento e do bem-estar. Aqui, o risco é tratar como estresse inespecífico algo que pede checagem médica mais breve.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Carbamazepina é um anticonvulsivante que também pode aparecer no consultório em pacientes com transtorno bipolar, dor neuropática e alguns quadros neurológicos. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta costuma acompanhar mais de perto sedação, lentificação, tontura, instabilidade subjetiva e impacto funcional, que podem confundir a leitura do humor e da motivação. Ao longo de algumas semanas, vale observar se há estabilização do padrão da sessão ou se persistem oscilação, adesão irregular e queixas físicas que alteram presença, cognição e vínculo. O ponto central é diferenciar efeito de início ou de retomada, flutuação do quadro de base e uso inconsistente.

Perguntas úteis

- "Quando você se percebe mais lento ou sonolento, isso fica parecido com tristeza e desânimo habituais ou parece mais um corpo pesado e uma cabeça menos nítida? , Essas oscilações de clareza e disposição acontecem de um dia para o outro sem relação clara com acontecimentos, ou costumam acompanhar conflitos, noites ruins e estresse? , Quando você sente menos intensidade emocional, isso vem como alívio da instabilidade ou como sensação de estar distante de si e das pessoas? , Nos dias em que você fica mais tonto, confuso ou irritado, houve alguma mudança na sua rotina de uso ou isso aparece mesmo mantendo tudo igual? , Essa dificuldade de atenção começou junto com este período do tratamento ou já fazia parte do seu funcionamento quando o humor estava pior? , Quando sua energia sobe, isso vem com mais organização e continuidade ou com aceleração, menos sono e sensação de que sua cabeça não desacelera?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- reduzir atividades ou cogitar abandonar o tratamento por sonolência
- tontura ou lentificação
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar impacto funcional e risco de adesão irregular
- Quando surgem oscilações marcadas entre sessões que não se explicam bem por eventos de vida e o paciente sugere uso inconsistente
- pode valer comunicar para qualificar a leitura clínica e evitar confundir descontinuidade com recaída
- Quando aparece sensação de embotamento importante
- perda de vivacidade ou queda cognitiva persistente que interfere no trabalho terapêutico e na rotina
- pode valer alinhar com o médico para revisão do quadro global
- Quando o paciente relata manchas na pele
- coceira importante
- febre
- mal-estar corporal ou piora física relevante em paralelo ao uso

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer contato mais breve com o médico pela necessidade de avaliação clínica
- Quando há persistência de instabilidade do humor
- impulsividade ou aceleração após algumas semanas
- apesar de aparente adesão
- pode valer comunicar para situar ausência de estabilização clínica esperada

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem manchas na pele
- vermelhidão disseminada
- feridas em boca ou olhos
- ou mal-estar importante com aspecto de adoecimento agudo.: Orientar busca de avaliação médica no mesmo dia; se houver piora rápida ou comprometimento importante do estado geral
- acionar emergência e rede de apoio
- Surge confusão acentuada
- fala muito enrolada
- desequilíbrio importante ou rebaixamento evidente do nível de alerta durante a sessão.: Interromper o trabalho clínico usual
- avaliar segurança imediata e acionar médico
- acompanhante ou serviço de urgência conforme a gravidade
- Há aumento de energia com redução importante do sono
- aceleração
- grandiosidade ou impulsividade fora do padrão habitual.: Tratar como possível virada de humor
- contatar o médico assistente no mesmo dia e acionar rede de apoio se houver risco comportamental

Frase clínica

O foco é separar estabilização do humor de lentificação, oscilação por adesão irregular e sinais físicos que mudam a presença do paciente em sessão.

030 CLONAZEPAM

Substância: Clonazepam.

Nomes Comerciais: Clonazepam, Clopam, Rivotril, Clonazepam (Port. 344/98 – Lista B1), Azenpi, Zilepam

Uso comum

- Clonazepam é um benzodiazepínico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade, insônia, crises de pânico e, às vezes, como medicação adjuvante em fases de maior desorganização emocional. No consultório, o mais útil é acompanhar três janelas: os primeiros dias, quando sedação, lentificação ou sensação de alívio rápido podem alterar bastante o padrão da sessão; as semanas seguintes, quando pode surgir uso mais frequente do que o inicialmente combinado pelo médico ou dificuldade de funcionar sem a medicação; e interrupções abruptas ou uso irregular, que podem ser seguidos em horas a poucos dias por piora importante de ansiedade, insônia, tremor e sensação de descontrole. O foco clínico é diferenciar contenção sintomática, sedação, oscilação por adesão irregular e evolução do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter fala mais lenta, menor prontidão associativa, sonolência, lapsos de atenção e redução da reatividade emocional. Isso pode ser lido apressadamente como melhora da ansiedade ou, no sentido oposto, como agravamento depressivo, quando às vezes há sobretudo efeito sedativo ou uso em horário próximo da sessão. Vale comparar com a baseline do paciente, com o horário da tomada referido por ele e com a consistência desse padrão entre sessões.

Ansiedade e alívio rápido: O paciente pode descrever queda rápida da tensão, menos antecipação catastrófica e sensação de finalmente conseguir respirar ou dormir. Esse alívio, porém, não equivale necessariamente a elaboração psíquica nem a mudança mais estável do funcionamento; em alguns casos, a evitação fica menos visível porque o desconforto foi amortecido. Também convém distinguir melhora ligada ao medicamento de redução de estressores externos, acolhimento do setting ou flutuação natural do quadro ansioso.

Uso situacional e dependência psicológica: Às vezes surge um vínculo muito estreito entre enfrentar situações e ter o comprimido por perto, com aumento da sensação de incapacidade sem ele. Na sessão, isso pode aparecer como perda de confiança nos próprios recursos, checagem constante de disponibilidade da medicação ou recusa de exposições antes toleráveis. Esse padrão pode se confundir com piora primária da ansiedade, mas ganha outra leitura quando a autonomia diminui justamente após um período de alívio rápido e uso recorrente em situações previsíveis.

Cognição e memória: Alguns pacientes ficam mais esquecidos, menos nítidos ao reconstruir eventos e com dificuldade de sustentar linha de pensamento, especialmente quando há cansaço, privação de sono, álcool ou outras medicações sedativas em jogo. Em terapia, isso pode empobrecer a elaboração, fragmentar a narrativa e gerar aparente resistência que não corresponde ao vínculo. Também é importante não atribuir tudo ao clonazepam quando o próprio quadro ansioso, o humor deprimido ou noites ruins já comprometiam atenção e memória antes.

Adesão e descontinuação: Uso irregular é frequente: o paciente alterna dias de tomada, aumenta por conta própria em momentos de crise ou interrompe quando se sente melhor ou teme dependência. Na sessão, isso costuma aparecer como oscilação abrupta entre contenção e desorganização, às vezes com ansiedade intensa, insônia, irritabilidade, tremor ou sensação de estranheza após horas ou poucos dias sem usar. Sem perguntar diretamente sobre o padrão real de uso, o terapeuta pode confundir esse vaivém com recaída, instabilidade de personalidade ou falha global do tratamento.

Vínculo e acesso afetivo: Quando há embotamento, sonolência ou alívio muito imediato, o trabalho pode ficar mais concreto e menos simbolizado, com menor acesso a nuances afetivas e menor tolerância para explorar conflito. Em outros casos, a redução da ansiedade permite aproximação inédita de temas antes evitados. O ponto é observar se a medicação está ampliando a capacidade de estar na sessão ou se está achatando a experiência a ponto de reduzir presença psíquica, sempre em comparação com o funcionamento prévio do paciente."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter fala mais lenta, menor prontidão associativa, sonolência, lapsos de atenção e redução da reatividade emocional. Isso pode ser lido apressadamente como melhora da ansiedade ou, no sentido oposto, como agravamento depressivo, quando às vezes há sobretudo efeito sedativo ou uso em horário próximo da sessão. Vale comparar com a baseline do paciente, com o horário da tomada referido por ele e com a consistência desse padrão entre sessões.

Ansiedade e alívio rápido: O paciente pode descrever queda rápida da tensão, menos antecipação catastrófica e sensação de finalmente conseguir respirar ou dormir. Esse alívio, porém, não equivale necessariamente a elaboração psíquica nem a mudança mais estável do funcionamento; em alguns casos, a evitação fica menos visível porque o desconforto foi amortecido. Também convém distinguir melhora ligada ao medicamento de redução de estressores externos, acolhimento do setting ou flutuação natural do quadro ansioso.

Uso situacional e dependência psicológica: Às vezes surge um vínculo muito estreito entre enfrentar situações e ter o comprimido por perto, com aumento da sensação de incapacidade sem ele. Na sessão, isso pode aparecer como perda de confiança nos próprios recursos, checagem constante de disponibilidade da medicação ou recusa de exposições antes toleráveis. Esse padrão pode se confundir com piora primária da ansiedade, mas ganha outra leitura quando a autonomia diminui justamente após um período de alívio rápido e uso recorrente em situações previsíveis.

Cognição e memória: Alguns pacientes ficam mais esquecidos, menos nítidos ao reconstruir eventos e com dificuldade de sustentar linha de pensamento, especialmente quando há cansaço, privação de sono, álcool ou outras medicações sedativas em jogo. Em terapia, isso pode empobrecer a elaboração, fragmentar a narrativa e gerar aparente resistência que não corresponde ao vínculo. Também é importante não atribuir tudo ao clonazepam quando o próprio quadro ansioso, o humor deprimido ou noites ruins já comprometiam atenção e memória antes.

Adesão e descontinuação: Uso irregular é frequente: o paciente alterna dias de tomada, aumenta por conta própria em momentos de crise ou interrompe quando se sente melhor ou teme dependência. Na sessão, isso costuma aparecer como oscilação abrupta entre contenção e desorganização, às vezes com ansiedade intensa, insônia, irritabilidade, tremor ou sensação de estranheza após horas ou poucos dias sem usar. Sem perguntar diretamente sobre o padrão real de uso, o terapeuta pode confundir esse vaivém com recaída, instabilidade de personalidade ou falha global do tratamento.

Vínculo e acesso afetivo: Quando há embotamento, sonolência ou alívio muito imediato, o trabalho pode ficar mais concreto e menos simbolizado, com menor acesso a nuances afetivas e menor tolerância para explorar conflito. Em outros casos, a redução da ansiedade permite aproximação inédita de temas antes evitados. O ponto é observar se a medicação está ampliando a capacidade de estar na sessão ou se está achatando a experiência a ponto de reduzir presença psíquica, sempre em comparação com o funcionamento prévio do paciente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Clonazepam é um benzodiazepínico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade, insônia, crises de pânico e, às vezes, como medicação adjuvante em fases de maior desorganização emocional. No consultório, o mais útil é acompanhar três janelas: os primeiros dias, quando sedação, lentificação ou sensação de alívio rápido podem alterar bastante o padrão da sessão; as semanas seguintes, quando pode surgir uso mais frequente do que o inicialmente combinado pelo médico ou dificuldade de funcionar sem a medicação; e interrupções abruptas ou uso irregular, que podem ser seguidos em horas a poucos dias por piora importante de ansiedade, insônia, tremor e sensação de descontrole. O foco clínico é diferenciar contenção sintomática, sedação, oscilação por adesão irregular e evolução do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais calmo, isso vem junto com mais clareza para pensar e escolher, ou com uma sensação de ficar meio apagado e apenas menos tenso? , Nos dias em que a ansiedade piora de repente, aconteceu alguma mudança no seu jeito de usar a medicação nas últimas 24 a 72 horas? , Essa dificuldade de memória e atenção já vinha antes ou ficou mais perceptível depois que você começou a usar o remédio ou mudou o padrão de uso? , Quando você imagina enfrentar uma situação difícil sem ter a medicação à mão, o que aparece: medo de a ansiedade voltar ao seu padrão antigo ou sensação de que você não consegue funcionar sem ela? , Seu cansaço e lentidão ficam parecidos o dia todo ou parecem mais fortes em certos horários, especialmente perto de quando você usa a medicação? , Quando você dorme melhor, no dia seguinte se sente realmente mais restaurado ou apenas mais amortecido e lento?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente muito sonolento
- lentificado ou com prejuízo claro de atenção e memória que interfere no trabalho terapêutico e na rotina
- pode valer alinhar com o médico assistente para informar impacto funcional observado
- Quando aparecem oscilações bruscas de ansiedade
- insônia
- irritabilidade ou tremor associadas a interrupções
- esquecimentos ou uso em padrão muito irregular
- pode valer comunicar o médico para esclarecer se há descontinuação ou manejo inconsistente
- Quando o paciente passa a evitar compromissos
- deslocamentos ou exposições sem a medicação por perto e relata perda de autonomia que não era tão marcada antes
- pode valer alinhar com o médico pela mudança clínica no funcionamento
- Quando há uso combinado com álcool ou outros sedativos referido em sessão
- sobretudo com episódios de apagamento
- confusão ou risco comportamental

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicação com o médico assistente pela relevância clínica imediata
- Quando
- após semanas
- o alívio rápido convive com manutenção importante de evitação
- sofrimento ou prejuízo funcional
- pode valer contato com o médico para compartilhar que a contenção sintomática não está se traduzindo em melhora clínica mais ampla

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- há rebaixamento importante do nível de consciência
- dificuldade de se manter acordado
- fala muito arrastada e desorientação
- especialmente se houver menção a álcool ou outras substâncias.: Interromper o trabalho interpretativo
- avaliar segurança imediata
- acionar rede de apoio e buscar avaliação médica no mesmo dia; emergência pode ser necessária conforme o estado clínico
- Após interrupção abrupta referida
- o paciente chega muito agitado
- trêmulo
- confuso ou relata piora súbita importante com risco de não conseguir se manter seguro.: Tratar como situação de urgência clínica
- acionar o médico assistente no mesmo dia e mobilizar rede de apoio e emergência se houver rebaixamento de segurança
- Há ideação suicida com aumento recente de desinibição
- impulsividade ou uso de álcool e sedativos no contexto de sofrimento agudo.: Fazer manejo de risco na própria sessão e acionar imediatamente psiquiatra
- rede de apoio e serviços de urgência quando necessário

Frase clínica

Com clonazepam, o ponto central é diferenciar alívio rápido da ansiedade, sedação e oscilação por uso irregular.

031 DIVALPROATO DE SÓDIO

Substância: Divalproato de Sódio.

Nomes Comerciais: Gaba Er, Divalproato de Sódio, Duepoli Er, Leps Er, Depakote, Divalcon, Valpi, Divalproato de Sodio, Zeugma Xr

Uso comum

- Divalproato de sódio é um anticonvulsivante também usado em psiquiatria, sobretudo em quadros bipolares, irritabilidade importante e contextos em que se busca reduzir instabilidade de humor. No consultório, costuma aparecer mais pelo efeito sobre intensidade, impulsividade, sono e ritmo psíquico do que por uma “melhora antidepressiva” direta. Nas primeiras 1 a 3 semanas vale acompanhar sedação, lentificação, desconfortos físicos e mudanças no apetite; ao longo de 2 a 6 semanas pode ficar mais claro se houve redução de reatividade e aceleração. O ponto central na sessão é diferenciar estabilização útil de embotamento, sedação ou adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Ritmo psíquico:** Quando o medicamento está ajudando, parte dos pacientes chega menos acelerada, com menor pressão interna, menos impulsividade e maior capacidade de sustentar um tema sem dispersar tanto. Isso pode se confundir com exaustão após crise, efeito de contenção ambiental ou simples alívio por eventos externos terem se organizado. Também vale considerar adesão irregular quando a sessão mostra alternância brusca entre dias muito mais acelerados e outros excessivamente lentos, sem um padrão clínico claro.

Sedação e lentificação: Sonolência, fala mais arrastada, maior latência para responder e redução da vivacidade podem aparecer sobretudo no início ou após mudanças recentes no tratamento referidas pelo paciente. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, retraimento defensivo ou desinvestimento do processo, quando às vezes o eixo principal é tolerabilidade. A discriminação depende de comparar com a baseline: há tristeza, culpa e desesperança associadas, ou predomina cansaço com menor velocidade mental?

Humor e irritabilidade: Em alguns casos, o ganho clínico aparece menos como euforia ausente e mais como queda de explosividade, menor propensão a discussões e recuperação mais rápida após frustração. Esse movimento pode ser confundido com evitação emocional, submissão relacional ou esgotamento depois de semanas turbulentas. Se a irritabilidade persiste apesar de aparente sedação, ou se o paciente descreve picos de raiva em dias específicos, vale manter em mente tanto fatores contextuais quanto uso irregular.

Apetite e peso: Aumento de fome, mudanças no padrão alimentar e incômodo com peso podem entrar na sessão de modo indireto, como piora de autoestima, vergonha corporal ou abandono de atividades. Às vezes o paciente atribui toda mudança ao remédio, mas rotina mais sedentária, melhora do sono, comer emocional e outras medicações também podem participar. Como esse tema favorece abandono silencioso, convém observar quando o incômodo corporal começa a competir com a adesão e com o vínculo do paciente ao tratamento.

Cognição e elaboração: Alguns pacientes descrevem pensamento menos caótico, o que facilita elaboração; outros referem sensação de cabeça mais pesada, menor agilidade verbal ou dificuldade de organizar nuances. Na sessão, isso pode parecer resistência, empobrecimento associativo ou menor acesso afetivo, embora nem sempre represente fechamento defensivo. A leitura fica mais precisa quando se compara a qualidade da reflexão com o nível de energia, o sono recente e a presença de outras substâncias sedativas.

Adesão e continuidade: Com divalproato, a adesão pode oscilar quando o paciente se sente "bom demais para continuar", quando se incomoda com sedação ou peso, ou quando a melhora da impulsividade reduz a percepção de necessidade do tratamento. Na clínica, isso aparece como narrativa vaga sobre horários, esquecimentos frequentes, retomadas por conta própria ou pioras que surgem após fins de semana e viagens. Nem toda oscilação é descontinuação, mas mudanças abruptas no padrão da sessão sem explicação contextual costumam pedir exploração mais direta."

O que observar em sessão

- **Ritmo psíquico:** Quando o medicamento está ajudando, parte dos pacientes chega menos acelerada, com menor pressão interna, menos impulsividade e maior capacidade de sustentar um tema sem dispersar tanto. Isso pode se confundir com exaustão após crise, efeito de contenção ambiental ou simples alívio por eventos externos terem se organizado. Também vale considerar adesão irregular quando a sessão mostra alternância brusca entre dias muito mais acelerados e outros excessivamente lentos, sem um padrão clínico claro.

Sedação e lentificação: Sonolência, fala mais arrastada, maior latência para responder e redução da vivacidade podem aparecer sobretudo no início ou após mudanças recentes no tratamento referidas pelo paciente. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, retraimento defensivo ou desinvestimento do processo, quando às vezes o eixo principal é tolerabilidade. A discriminação depende de comparar com a baseline: há tristeza, culpa e desesperança associadas, ou predomina cansaço com menor velocidade mental?

Humor e irritabilidade: Em alguns casos, o ganho clínico aparece menos como euforia ausente e mais como queda de explosividade, menor propensão a discussões e recuperação mais rápida após frustração. Esse movimento pode ser confundido com evitação emocional, submissão relacional ou esgotamento depois de semanas turbulentas. Se a irritabilidade persiste apesar de aparente sedação, ou se o paciente descreve picos de raiva em dias específicos, vale manter em mente tanto fatores contextuais quanto uso irregular.

Apetite e peso: Aumento de fome, mudanças no padrão alimentar e incômodo com peso podem entrar na sessão de modo indireto, como piora de autoestima, vergonha corporal ou abandono de atividades. Às vezes o paciente atribui toda mudança ao remédio, mas rotina mais sedentária, melhora do sono, comer emocional e outras medicações também podem participar. Como esse tema favorece abandono silencioso, convém observar quando o incômodo corporal começa a competir com a adesão e com o vínculo do paciente ao tratamento.

Cognição e elaboração: Alguns pacientes descrevem pensamento menos caótico, o que facilita elaboração; outros referem sensação de cabeça mais pesada, menor agilidade verbal ou dificuldade de organizar nuances. Na sessão, isso pode parecer resistência, empobrecimento associativo ou menor acesso afetivo, embora nem sempre represente fechamento defensivo. A leitura fica mais precisa quando se compara a qualidade da reflexão com o nível de energia, o sono recente e a presença de outras substâncias sedativas.

Adesão e continuidade: Com divalproato, a adesão pode oscilar quando o paciente se sente “bom demais para continuar”, quando se incomoda com sedação ou peso, ou quando a melhora da impulsividade reduz a percepção de necessidade do tratamento. Na clínica, isso aparece como narrativa vaga sobre horários, esquecimentos frequentes, retomadas por conta própria ou pioras que surgem após fins de semana e viagens. Nem toda oscilação é descontinuação, mas mudanças abruptas no padrão da sessão sem explicação contextual costumam pedir exploração mais direta.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Divalproato de sódio é um anticonvulsivante também usado em psiquiatria, sobretudo em quadros bipolares, irritabilidade importante e contextos em que se busca reduzir instabilidade de humor. No consultório, costuma aparecer mais pelo efeito sobre intensidade, impulsividade, sono e ritmo psíquico do que por uma “melhora antidepressiva” direta. Nas primeiras 1 a 3 semanas vale acompanhar sedação, lentificação, desconfortos físicos e mudanças no apetite; ao longo de 2 a 6 semanas pode ficar mais claro se houve redução de reatividade e aceleração. O ponto central na sessão é diferenciar estabilização útil de embotamento, sedação ou adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais calmo, isso vem junto com mais clareza para pensar e escolher, ou com uma sensação de estar amortecido e mais devagar do que gostaria? , Nesses dias em que parece mais cansado, o que predomina: tristeza e desesperança, ou sono, corpo pesado e dificuldade de engrenar mesmo sem se sentir particularmente triste? , A irritabilidade diminuiu de forma relativamente contínua nas últimas semanas, ou você percebe dias muito diferentes entre si, como se houvesse oscilações sem motivo claro? , Quando sua fala e seu pensamento ficam mais lentos, você sente isso como alívio de uma aceleração anterior ou como perda de agilidade que está atrapalhando seu funcionamento? , As mudanças no apetite e no corpo começaram junto com essa fase do tratamento, ou vieram mais com alterações de rotina, sono, ansiedade ou alimentação emocional? , Nos períodos em que você piora de repente, houve algo diferente na forma como você vinha tomando a medicação ou na sua rotina de sono e uso de outras substâncias?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente mostra redução da aceleração
- mas à custa de lentificação importante
- sonolência persistente ou prejuízo funcional percebido
- pode valer alinhar com o psiquiatra para qualificar se o custo subjetivo está comprometendo a continuidade do tratamento
- Quando surgem sinais de abandono silencioso por incômodo com peso
- apetite ou sensação de embotamento
- pode valer comunicar o médico assistente porque esses fatores frequentemente interferem na adesão antes que o paciente verbalize isso na consulta
- Quando a sessão traz oscilação importante de humor
- irritabilidade ou impulsividade apesar de algumas semanas de uso
- pode valer contato com o psiquiatra para diferenciar resposta parcial
- adesão irregular ou outra evolução do quadro
- Quando o paciente descreve interrupções
- esquecimentos repetidos ou retomadas por conta própria

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico assistente porque a leitura clínica da oscilação fica menos confiável e o risco de piora aumenta
- Quando aparecem queixas cognitivas novas e persistentes
- com impacto claro em trabalho
- estudo ou capacidade de sustentar a sessão
- pode valer comunicação para que isso entre na avaliação global do tratamento

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecimento de confusão acentuada
- fala muito desorganizada
- sonolência incomum
- desequilíbrio para andar
- vômitos repetidos ou rebaixamento importante do estado geral durante a sessão ou nas horas anteriores.: Tratar como urgência clínica
- orientar busca de avaliação médica no mesmo dia e acionar rede de apoio e emergência quando necessário
- Retorno de aceleração intensa com redução importante de sono
- grandiosidade
- impulsividade ou agitação que destoa nitidamente da baseline
- sobretudo se vier com risco financeiro
- sexual ou interpessoal.: Acionar o psiquiatra no mesmo dia e manejar a segurança com rede de apoio
- considerando avaliação urgente se houver perda de juízo crítico
- Ideação suicida que surge ou se intensifica junto de piora abrupta do humor
- agitação
- impulsividade ou sensação de descontrole.: Fazer avaliação de risco na sessão
- acionar psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhar para emergência se a contenção ambulatorial não parecer suficiente

Frase clínica

O foco é distinguir estabilização útil de sedação, embotamento e adesão irregular ao acompanhar a oscilação de humor na sessão.

032 ETOSSUXIMIDA

Substância: Etossuximida.

Nomes Comerciais: Etoxin

Uso comum

- Etossuximida é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsias com crises de ausência, situação menos frequente no consultório de psicoterapia do que os psicofármacos usuais. Para o terapeuta, o ponto central costuma ser menos um “efeito psíquico típico” e mais como o controle das crises, a regularidade do uso e a tolerabilidade interferem em atenção, energia, ritmo da sessão e vida escolar ou laboral. Mudanças percebidas nas primeiras semanas após início ou retomada podem se misturar com adaptação à rotina, privação de sono, outras medicações e impacto subjetivo de conviver com uma condição neurológica crônica. Vale acompanhar o padrão ao longo de algumas semanas e comparar com a linha de base.

O paciente pode relatar

- **"Atenção e ritmo:** Em sessão, podem aparecer lentificação, oscilação de atenção, dificuldade de sustentar o fio associativo ou sensação de “cabeça mais pesada”, mas isso também pode refletir sono ruim, crises subclínicas, ansiedade antecipatória ou sobrecarga escolar e ocupacional. Quando a mudança surge perto do início do tratamento ou de retomadas irregulares, vale registrar a temporalidade sem concluir causalidade. A comparação com a baseline cognitiva do paciente e com horários do dia costuma ajudar mais do que uma leitura isolada de uma sessão.

Sono e energia: Alguns pacientes chegam mais sonolentos, menos responsivos ou com menor energia disponível para elaboração, o que pode ser confundido com humor deprimido, exaustão por crises, rotina desorganizada ou uso concomitante de outras medicações sedativas. Se a sonolência varia muito entre sessões, vale observar se acompanha noites mal dormidas, faltas, esquecimentos ou mudanças recentes na rotina. O dado clinicamente útil é o impacto funcional: adormecer em atividades, faltar compromissos ou perder rendimento de forma nova.

Adesão e regularidade: Como se trata de tratamento contínuo, esquecimentos, uso irregular ou interrupções silenciosas podem aparecer indiretamente como piora de concentração, medo de novas crises, constrangimento social ou retorno de episódios breves de desligamento. Em psicoterapia, o paciente nem sempre nomeia isso como questão de adesão; às vezes surge como “fase ruim”, irritação com a rotina de tratamento ou ambivalência em relação à identidade de alguém que precisa de medicação. Diferenciar sofrimento com a condição de base de irregularidade no uso ajuda a não atribuir tudo ao estado emocional.

Carga da condição: O impacto subjetivo de viver com epilepsia costuma ter mais peso clínico na sessão do que um perfil psicológico específico da etossuximida. Restrições percebidas, medo de passar mal em público, vergonha, dependência da supervisão familiar e sensação de diferença em relação aos pares podem organizar o sofrimento e afetar autonomia, autoestima e vínculo. Em alguns casos, melhora clínica das crises não reduz imediatamente a ansiedade, porque o paciente permanece orientado pelo risco e pela vigilância aprendida."

O que observar em sessão

- **Atenção e ritmo:** Em sessão, podem aparecer lentificação, oscilação de atenção, dificuldade de sustentar o fio associativo ou sensação de “cabeça mais pesada”, mas isso também pode refletir sono ruim, crises subclínicas, ansiedade antecipatória ou sobrecarga escolar e ocupacional. Quando a mudança surge perto do início do tratamento ou de retomadas irregulares, vale registrar a temporalidade sem concluir causalidade. A comparação com a baseline cognitiva do paciente e com horários do dia costuma ajudar mais do que uma leitura isolada de uma sessão.

Sono e energia: Alguns pacientes chegam mais sonolentos, menos responsivos ou com menor energia disponível para elaboração, o que pode ser confundido com humor deprimido, exaustão por crises, rotina desorganizada ou uso concomitante de outras medicações sedativas. Se a sonolência varia muito entre sessões, vale observar se acompanha noites mal dormidas, faltas, esquecimentos ou mudanças recentes na rotina. O dado clinicamente útil é o impacto funcional: adormecer em atividades, faltar compromissos ou perder rendimento de forma nova.

Adesão e regularidade: Como se trata de tratamento contínuo, esquecimentos, uso irregular ou interrupções silenciosas podem aparecer indiretamente como piora de concentração, medo de novas crises, constrangimento social ou retorno de episódios breves de desligamento. Em psicoterapia, o paciente nem sempre nomeia isso como questão de adesão; às vezes surge como “fase ruim”, irritação com a rotina de tratamento ou ambivalência em relação à identidade de alguém que precisa de medicação. Diferenciar sofrimento com a condição de base de irregularidade no uso ajuda a não atribuir tudo ao estado emocional.

Carga da condição: O impacto subjetivo de viver com epilepsia costuma ter mais peso clínico na sessão do que um perfil psicológico específico da etossuximida. Restrições percebidas, medo de passar mal em público, vergonha, dependência da supervisão familiar e sensação de diferença em relação aos pares podem organizar o sofrimento e afetar autonomia, autoestima e vínculo. Em alguns casos, melhora clínica das crises não reduz imediatamente a ansiedade, porque o paciente permanece orientado pelo risco e pela vigilância aprendida.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Etossuximida é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsias com crises de ausência, situação menos frequente no consultório de psicoterapia do que os psicofármacos usuais. Para o terapeuta, o ponto central costuma ser menos um “efeito psíquico típico” e mais como o controle das crises, a regularidade do uso e a tolerabilidade interferem em atenção, energia, ritmo da sessão e vida escolar ou laboral. Mudanças percebidas nas primeiras semanas após início ou retomada podem se misturar com adaptação à rotina, privação de sono, outras medicações e impacto subjetivo de conviver com uma condição neurológica crônica. Vale acompanhar o padrão ao longo de algumas semanas e comparar com a linha de base.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou disperso, isso aparece como sonolência e peso no corpo ou como mente acelerada que não consegue se fixar? , Esses momentos de “desligamento” que você percebe têm cara de cansaço comum, de distração por preocupação, ou parecem episódios abruptos e diferentes do seu padrão habitual? , A dificuldade de manter atenção começou junto com alguma mudança no tratamento ou já vinha se desenhando antes, em paralelo a estresse, sono ruim ou aumento das demandas? , Quando você falha no uso ou muda a rotina por alguns dias, percebe alguma diferença no seu funcionamento, no medo de ter crises ou na sua confiança para sair e trabalhar? , O que mais tem pesado hoje: efeitos no seu ritmo e disposição, ou o impacto de viver atento à possibilidade de uma crise acontecer?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve retorno ou aumento de episódios breves de desligamento
- confusão súbita ou quedas no funcionamento que lembram pior controle das crises
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a mudança no curso do tratamento
- Quando a sonolência
- lentificação ou dificuldade de atenção passam a comprometer escola
- trabalho
- direção ou presença mínima na sessão
- pode valer comunicar para avaliação da tolerabilidade e do impacto funcional
- Quando surgem esquecimentos frequentes
- interrupções por conta própria ou uso muito irregular
- especialmente acompanhados de piora clínica ou medo de novas crises
- pode valer alinhar com o médico pela relevância da regularidade do tratamento
- Quando aparecem náusea persistente
- mal-estar importante ou aversão ao medicamento a ponto de o paciente cogitar abandono silencioso
- pode valer comunicar para prevenir ruptura do cuidado
- Quando há mudança importante de humor
- irritabilidade incomum ou retraimento marcante sem explicação suficiente por eventos de vida
- pode valer compartilhar a observação para avaliação clínica mais ampla
- sobretudo se coincidiu com início ou retomada recente

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente apresenta rebaixamento importante do nível de consciência
- confusão acentuada

Vermelho: tratar como urgência

- dificuldade de se orientar ou sinais de crise em curso ou muito recente.: Interromper o trabalho terapêutico
- acionar suporte imediato e buscar avaliação médica urgente ou emergência conforme o contexto
- Surge ideação suicida com intenção
- plano ou perda importante de controle
- independentemente de a relação com a medicação estar clara.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e encaminhar para avaliação urgente conforme a gravidade

Frase clínica

O foco clínico costuma estar menos no fármaco em si e mais em como crises, regularidade do uso e tolerabilidade atravessam atenção, autonomia e rotina.

033 FENITOÍNA

Substância: Fenitoína.

Nomes Comerciais: Fenital Oral, Fenitoína, Dantalin, Furp - Fenitoina, Hidantal

Uso comum

- A fenitoína é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsia e, no consultório de terapia, costuma aparecer mais como parte do manejo de uma condição neurológica crônica do que como foco principal do tratamento psíquico. Não há uma janela terapêutica subjetiva tão nítida quanto em psicofármacos, mas mudanças após início, troca de apresentação, retomada irregular ou interrupção por alguns dias merecem atenção nas primeiras semanas. O ponto central na sessão é distinguir lentificação, oscilação de atenção, instabilidade de rotina e sofrimento ligado à doença de base de efeitos percebidos após mudanças no uso ou de adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Cognição e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer fala mais lenta, dificuldade de encontrar palavras, atenção flutuante ou sensação de estar "mais travado". Isso pode ser confundido com depressão, exaustão, privação de sono, efeitos de outras medicações sedativas ou impacto pós- crise convulsiva. Vale comparar com a linha de base do paciente e observar se a lentificação é estável ao longo das sessões ou se aparece em torno de mudanças recentes no uso, noites mal dormidas ou períodos de maior desorganização clínica.

Equilíbrio e coordenação: Tontura, marcha menos firme, sensação de desequilíbrio ou maior insegurança corporal podem aparecer no relato e, às vezes, ficam visíveis no modo como o paciente entra na sala, se senta ou muda de posição. Na leitura clínica, isso pode se misturar com ansiedade somatizada, fraqueza, uso concomitante de outras medicações ou efeitos residuais de eventos neurológicos recentes. Quando o paciente descreve piora súbita ou progressiva desses sinais, a observação do terapeuta ganha valor como registro objetivo para eventual comunicação com o médico assistente.

Humor e irritabilidade: Alguns pacientes chegam mais irritáveis, com menor tolerância a frustração, oscilação de humor ou sensação de estranhamento subjetivo desde mudanças no tratamento. Esse quadro pode refletir estresse por conviver com epilepsia, restrições funcionais, medo de novas crises, conflitos familiares em torno do cuidado ou sofrimento psíquico prévio, e não necessariamente o medicamento em si. Na sessão, ajuda notar se a irritabilidade vem acompanhada de lentificação, mal-estar físico, piora do sono ou desorganização da rotina, porque isso muda a hipótese clínica mais provável.

Adesão e rotina: A adesão pode oscilar silenciosamente quando o paciente se sente bem, teme efeitos indesejados, perde horários ou vive uma rotina pouco previsível. Em terapia, isso costuma aparecer de forma indireta: relato de esquecimentos, vergonha de admitir uso irregular, explicações vagas para dias "estranhos" ou aumento do medo de ter crise sem clareza sobre o que mudou. Diferenciar sofrimento emocional da condição de base de irregularidade no uso é central, porque pequenas rupturas na rotina podem ter impacto clínico relevante e passar despercebidas se o terapeuta olhar apenas para o conteúdo afetivo.

Carga do tratamento: Como se trata de um medicamento ligado a uma condição potencialmente limitante, a sessão frequentemente gira em torno de autonomia, restrições, dependência de terceiros, receio de crises em público e identidade de pessoa doente. O sofrimento pode se intensificar após episódios recentes, exames, orientações médicas ou mudanças na vida prática, sem relação direta com o remédio. Nesses casos, o foco do terapeuta é sustentar elaboração e funcionalidade sem perder de vista que alterações subjetivas e corporais podem estar entrelaçadas ao manejo clínico da epilepsia."

O que observar em sessão

- **Cognição e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer fala mais lenta, dificuldade de encontrar palavras, atenção flutuante ou sensação de estar “mais travado”. Isso pode ser confundido com depressão, exaustão, privação de sono, efeitos de outras medicações sedativas ou impacto pós-crise convulsiva. Vale comparar com a linha de base do paciente e observar se a lentificação é estável ao longo das sessões ou se aparece em torno de mudanças recentes no uso, noites mal dormidas ou períodos de maior desorganização clínica.

Equilíbrio e coordenação: Tontura, marcha menos firme, sensação de desequilíbrio ou maior insegurança corporal podem aparecer no relato e, às vezes, ficam visíveis no modo como o paciente entra na sala, se senta ou muda de posição. Na leitura clínica, isso pode se misturar com ansiedade somatizada, fraqueza, uso concomitante de outras medicações ou efeitos residuais de eventos neurológicos recentes. Quando o paciente descreve piora súbita ou progressiva desses sinais, a observação do terapeuta ganha valor como registro objetivo para eventual comunicação com o médico assistente.

Humor e irritabilidade: Alguns pacientes chegam mais irritáveis, com menor tolerância a frustração, oscilação de humor ou sensação de estranhamento subjetivo desde mudanças no tratamento. Esse quadro pode refletir estresse por conviver com epilepsia, restrições funcionais, medo de novas crises, conflitos familiares em torno do cuidado ou sofrimento psíquico prévio, e não necessariamente o medicamento em si. Na sessão, ajuda notar se a irritabilidade vem acompanhada de lentificação, mal-estar físico, piora do sono ou desorganização da rotina, porque isso muda a hipótese clínica mais provável.

Adesão e rotina: A adesão pode oscilar silenciosamente quando o paciente se sente bem, teme efeitos indesejados, perde horários ou vive uma rotina pouco previsível. Em terapia, isso costuma aparecer de forma indireta: relato de esquecimentos, vergonha de admitir uso irregular, explicações vagas para dias “estranhos” ou aumento do medo de ter crise sem clareza sobre o que mudou. Diferenciar sofrimento emocional da condição de base de irregularidade no uso é central, porque pequenas rupturas na rotina podem ter impacto clínico relevante e passar despercebidas se o terapeuta olhar apenas para o conteúdo afetivo.

Carga do tratamento: Como se trata de um medicamento ligado a uma condição potencialmente limitante, a sessão frequentemente gira em torno de autonomia, restrições, dependência de terceiros, receio de crises em público e identidade de pessoa doente. O sofrimento pode se intensificar após episódios recentes, exames, orientações médicas ou mudanças na vida prática, sem relação direta com o remédio. Nesses casos, o foco do terapeuta é sustentar elaboração e funcionalidade sem perder de vista que alterações subjetivas e corporais podem estar entrelaçadas ao manejo clínico da epilepsia.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A fenitoína é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsia e, no consultório de terapia, costuma aparecer mais como parte do manejo de uma condição neurológica crônica do que como foco principal do tratamento psíquico. Não há uma janela terapêutica subjetiva tão nítida quanto em psicofármacos, mas mudanças após início, troca de apresentação, retomada irregular ou interrupção por alguns dias merecem atenção nas primeiras semanas. O ponto central na sessão é distinguir lentificação, oscilação de atenção, instabilidade de rotina e sofrimento ligado à doença de base de efeitos percebidos após mudanças no uso ou de adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou confuso, isso parece constante ao longo do dia ou acontece em momentos específicos, como após noites ruins, crises, esquecimentos ou mudanças recentes na rotina? , Essa irritabilidade que apareceu vem mais como impaciência corporal e mal-estar, ou está ligada a pensamentos, conflitos e situações reconhecíveis da sua semana? , Quando você fala em tontura ou desequilíbrio, isso surgiu junto de ansiedade e tensão, ou você percebe mesmo no corpo uma instabilidade nova ao andar, levantar ou mudar de posição? , Nos dias em que você se sente diferente, houve alguma quebra no seu padrão habitual de tomar a medicação, dormir, se alimentar ou organizar horários? , O que mudou mais desde o início desse período: seu humor e sua disposição para a vida, ou sua clareza mental, seu corpo e seu ritmo para fazer as coisas?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a mostrar lentificação
- confusão
- fala arrastada ou desequilíbrio mais evidentes do que sua linha de base
- pode valer alinhar com o médico assistente para checar se há relação com o tratamento ou com a condição neurológica
- Quando surgem esquecimentos frequentes
- uso irregular admitido ou interrupções por conta própria
- pode valer comunicar o médico porque a adesão inconsistente pode aumentar instabilidade clínica e risco de novas crises
- Quando o paciente relata piora importante de irritabilidade
- mal-estar subjetivo ou queda funcional após início
- troca de apresentação ou retomada do medicamento
- pode valer alinhar com o médico para contextualizar a mudança clínica
- Quando aparecem lesões de pele
- febre ou mal-estar físico relevante junto de mudança recente no uso
- a comunicação com o médico ganha prioridade pela necessidade de avaliação clínica oportuna

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- o paciente parece confuso de forma acentuada
- muito instável para andar
- com fala bastante arrastada ou rebaixamento importante do estado geral.: Interromper o enquadre habitual
- acionar suporte imediato
- contatar médico e rede de apoio e encaminhar para avaliação de urgência se necessário
- Surge relato ou observação de manchas na pele
- descamação
- feridas em mucosa
- febre ou mal-estar importante
- especialmente após início ou retomada recente.: Orientar busca de avaliação médica no mesmo dia e acionar rede de apoio e emergência quando houver comprometimento importante do estado geral

Frase clínica

Na terapia, o foco com fenitoína é diferenciar sofrimento da epilepsia e da rotina de cuidado de lentificação, desequilíbrio e adesão irregular.

034 FENITOÍNA SÓDICA

Substância: Fenitoína Sódica.

Nomes Comerciais: Fenital, Fenitoína Sódica

Uso comum

- A fenitoína sódica é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsia e, no consultório de terapia, costuma aparecer mais pelo contexto de uma condição neurológica crônica do que por um efeito psíquico específico. Mudanças subjetivas podem surgir logo após início, retomada, troca de apresentação ou uso irregular, enquanto dificuldades mais persistentes de atenção, lentificação, equilíbrio ou desconfortos físicos tendem a se tornar mais claras ao longo de dias a semanas. O ponto central na sessão é distinguir o que pertence ao curso das crises, ao impacto de viver com risco de recorrência, à adesão oscilante e ao possível peso cognitivo ou sedativo do tratamento.

O paciente pode relatar

- **"Cognição e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer lentificação, dificuldade para sustentar atenção, fala menos fluida ou sensação de estar "mais devagar". Isso pode ser confundido tanto com fadiga pós-crise e privação de sono quanto com humor deprimido, ansiedade elevada ou uso concomitante de outras medicações sedativas. Vale comparar com a linha de base do paciente, observar se a oscilação acompanha dias de crise, retomadas irregulares ou mudanças recentes na rotina, e registrar se o prejuízo aparece como algo novo ou progressivo.

Equilíbrio e coordenação: Instabilidade ao caminhar, tropeços, sensação de tontura ou pior coordenação motora podem aparecer no relato ou ser notados na chegada ao consultório. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como ansiedade somatizada, exaustão ou desorganização geral, quando às vezes o dado mais útil é a mudança concreta no corpo e na marcha. Se o paciente associa esses episódios a horários de tomada irregular, noites mal dormidas, crises recentes ou combinação com álcool e outros sedativos, a formulação clínica ganha precisão.

Humor e irritabilidade: Alguns pacientes ficam mais irritáveis, impacientes ou com menor tolerância a frustração, enquanto outros chegam mais apagados e com menos acesso afetivo. Esse quadro pode se confundir com sobrecarga de viver com epilepsia, restrições funcionais, medo de novas crises, conflitos familiares em torno de supervisão e autonomia, ou com o próprio transtorno de humor prévio. O terapeuta ganha mais clareza quando observa se a mudança é difusa e sustentada ou se aparece em torno de crises, falhas de adesão, piora do sono ou períodos de maior exigência externa.

Adesão e rotina: A adesão pode oscilar silenciosamente quando o paciente se sente bem, se incomoda com efeitos percebidos ou se desorganiza com horários rígidos. Na sessão, isso às vezes aparece indiretamente como narrativa vaga sobre esquecimentos, receio de depender de remédio, vergonha de tomar em público ou minimização de crises pequenas. Diferenciar resistência ao tratamento, desorganização executiva, negação defensiva e dificuldade prática de rotina ajuda mais do que tratar toda irregularidade como simples "falta de compromisso".

Carga da condição: Como a fenitoína costuma acompanhar uma condição neurológica de longa duração, o sofrimento em sessão frequentemente gira em torno de medo de ter crise, perda de autonomia, restrições para dirigir, trabalhar ou sair sozinho, e sensação de identidade marcada pela doença. Esse material pode ser confundido com ansiedade generalizada ou evitação de base, quando às vezes está ancorado em experiências concretas de imprevisibilidade corporal e vigilância familiar. Sustentar o trabalho terapêutico passa por reconhecer o peso do tratamento contínuo sem reduzir toda a vida psíquica do paciente à epilepsia."

O que observar em sessão

- **Cognição e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer lentificação, dificuldade para sustentar atenção, fala menos fluida ou sensação de estar “mais devagar”. Isso pode ser confundido tanto com fadiga pós- crise e privação de sono quanto com humor deprimido, ansiedade elevada ou uso concomitante de outras medicações sedativas. Vale comparar com a linha de base do paciente, observar se a oscilação acompanha dias de crise, retomadas irregulares ou mudanças recentes na rotina, e registrar se o prejuízo aparece como algo novo ou progressivo.

Equilíbrio e coordenação: Instabilidade ao caminhar, tropeços, sensação de tontura ou pior coordenação motora podem aparecer no relato ou ser notados na chegada ao consultório. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como ansiedade somatizada, exaustão ou desorganização geral, quando às vezes o dado mais útil é a mudança concreta no corpo e na marcha. Se o paciente associa esses episódios a horários de tomada irregular, noites mal dormidas, crises recentes ou combinação com álcool e outros sedativos, a formulação clínica ganha precisão.

Humor e irritabilidade: Alguns pacientes ficam mais irritáveis, impacientes ou com menor tolerância a frustração, enquanto outros chegam mais apagados e com menos acesso afetivo. Esse quadro pode se confundir com sobrecarga de viver com epilepsia, restrições funcionais, medo de novas crises, conflitos familiares em torno de supervisão e autonomia, ou com o próprio transtorno de humor prévio. O terapeuta ganha mais clareza quando observa se a mudança é difusa e sustentada ou se aparece em torno de crises, falhas de adesão, piora do sono ou períodos de maior exigência externa.

Adesão e rotina: A adesão pode oscilar silenciosamente quando o paciente se sente bem, se incomoda com efeitos percebidos ou se desorganiza com horários rígidos. Na sessão, isso às vezes aparece indiretamente como narrativa vaga sobre esquecimentos, receio de depender de remédio, vergonha de tomar em público ou minimização de crises pequenas. Diferenciar resistência ao tratamento, desorganização executiva, negação defensiva e dificuldade prática de rotina ajuda mais do que tratar toda irregularidade como simples “falta de compromisso”.

Carga da condição: Como a fenitoína costuma acompanhar uma condição neurológica de longa duração, o sofrimento em sessão frequentemente gira em torno de medo de ter crise, perda de autonomia, restrições para dirigir, trabalhar ou sair sozinho, e sensação de identidade marcada pela doença. Esse material pode ser confundido com ansiedade generalizada ou evitação de base, quando às vezes está ancorado em experiências concretas de imprevisibilidade corporal e vigilância familiar. Sustentar o trabalho terapêutico passa por reconhecer o peso do tratamento contínuo sem reduzir toda a vida psíquica do paciente à epilepsia.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A fenitoína sódica é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsia e, no consultório de terapia, costuma aparecer mais pelo contexto de uma condição neurológica crônica do que por um efeito psíquico específico. Mudanças subjetivas podem surgir logo após início, retomada, troca de apresentação ou uso irregular, enquanto dificuldades mais persistentes de atenção, lentificação, equilíbrio ou desconfortos físicos tendem a se tornar mais claras ao longo de dias a semanas. O ponto central na sessão é distinguir o que pertence ao curso das crises, ao impacto de viver com risco de recorrência, à adesão oscilante e ao possível peso cognitivo ou sedativo do tratamento.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais devagar ou confuso, isso costuma aparecer depois de uma crise, em dias de sono ruim, ou parece independente dessas situações? , Essa irritação que você percebe vem junto de mais energia e aceleração, ou vem mais como cansaço, incômodo corporal e menor tolerância? , Nos dias em que você esquece, atrasa ou evita tomar a medicação, você nota alguma mudança específica no corpo, no humor ou na sensação de segurança? , Quando você fala de desânimo, ele parece ligado ao medo de novas crises e às limitações da rotina, ou aparece mesmo em períodos mais estáveis da condição? , Essa sensação de tontura ou desequilíbrio surge em momentos de ansiedade e tensão, ou você percebe como algo mais corporal, que aparece mesmo sem gatilho emocional claro?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega com lentificação
- confusão
- desequilíbrio ou fala arrastada que fogem claramente da sua linha de base
- pode valer alinhar com o médico assistente para checar se há relação com o tratamento
- com crises recentes ou com uso irregular
- Quando aparecem esquecimentos frequentes
- interrupções por conta própria ou adesão muito oscilante
- pode valer comunicar o médico pela relevância disso no controle das crises e na leitura do quadro clínico
- Quando o paciente descreve piora cognitiva persistente que começa a comprometer trabalho
- estudo ou manejo básico da rotina
- pode valer alinhar com o médico para avaliação da tolerabilidade e do contexto neurológico
- Quando surgem irritabilidade importante
- retraimento acentuado ou mudança de humor que não se explica bem por eventos de vida ou pela linha de base
- pode valer comunicação para melhor discriminar condição de base
- crises e tratamento
- Quando há desconfortos físicos visíveis na sessão que aumentam risco de abandono silencioso do tratamento

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer avisar o médico assistente para favorecer uma leitura mais completa da adesão

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente aparece muito confuso
- sonolento
- cambaleante ou com fala bastante comprometida
- a ponto de não conseguir se orientar adequadamente.: Interromper o trabalho habitual
- acionar suporte imediato e contatar o médico e a rede de apoio no mesmo dia; considerar emergência conforme a gravidade
- Há relato de crise convulsiva recente com repetição
- recuperação incompleta
- queda importante ou novo rebaixamento do estado geral durante o atendimento.: Priorizar segurança
- acionar rede de apoio e avaliação médica imediata
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

O foco clínico costuma estar menos no fármaco em si e mais em como cognição, adesão e medo de novas crises reorganizam a vida psíquica do paciente.

035 FENOBARBITAL

Substância: Fenobarbital.

Nomes Comerciais: Fenobarbital, Fenocris, Carbital, Furp-Fenobarbital, Gardenal

Uso comum

- Fenobarbital é um barbitúrico usado principalmente como anticonvulsivante e, em alguns contextos, como sedativo. No consultório de terapia, tende a aparecer mais como parte do tratamento de epilepsia ou de quadros neurológicos crônicos do que como psicofármaco de uso corrente. Mudanças subjetivas podem surgir nos primeiros dias e semanas após início ou retomada, sobretudo em alerta, velocidade de pensamento, disposição e sono; com uso contínuo, o foco costuma se deslocar para adaptação da rotina, adesão e impacto funcional. O ponto central na sessão é diferenciar lentificação e sonolência relacionadas ao tratamento de humor deprimido, desmotivação, privação de sono, crises convulsivas recentes ou uso irregular.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão pode ganhar um tom de maior sonolência, fala mais lenta, latência aumentada para responder e menor iniciativa associativa. Isso pode ser confundido com retraimento depressivo, exaustão por noites ruins, efeito de outras medicações sedativas ou recuperação de uma crise convulsiva recente. Vale observar se a lentificação aparece como mudança de baseline, se varia conforme o horário da sessão e se o paciente a descreve como "corpo pesado" ou "mente mais devagar", porque essa distinção ajuda a não ler automaticamente como piora psíquica do quadro de base.

Cognição e atenção: Alguns pacientes referem dificuldade para manter foco, esquecer trechos de conversa, perder o fio do raciocínio ou sentir o pensamento menos ágil. Na sessão, isso pode aparecer como necessidade de repetição, empobrecimento narrativo ou menor capacidade de elaboração, mas também pode decorrer de ansiedade, crises epiléticas, privação de sono, dor crônica ou sobrecarga de vida. A discriminação clínica ganha precisão quando se acompanha a relação temporal entre essas queixas, mudanças recentes no tratamento e flutuações do funcionamento fora do consultório.

Humor e reatividade: Pode haver redução de energia, menor vivacidade afetiva e irritabilidade inespecífica, o que às vezes se mistura com frustração por limitações impostas pela condição neurológica de base. Em sessão, o terapeuta pode notar menos acesso afetivo ou menor reatividade emocional, mas isso não equivale necessariamente a depressão nem a efeito direto do medicamento. Eventos de vida, medo de novas crises, restrições na autonomia e adesão irregular podem produzir apresentação semelhante, por isso convém situar a mudança no contexto mais amplo do período.

Adesão e rotina: Como costuma ser usado em tratamento contínuo, a forma como o paciente organiza horários, lida com esquecimento e interpreta benefícios e incômodos do tratamento tem peso clínico importante. Faltas, uso irregular e ajustes feitos por conta própria podem aparecer indiretamente como oscilação de alerta, piora funcional ou narrativa confusa sobre o que mudou e quando mudou. Na sessão, mais do que checar tecnicamente o esquema, interessa mapear se há abandono silencioso, ambivalência com o tratamento ou dificuldade prática de sustentar a rotina.

Carga do tratamento: Quando o fenobarbital entra na vida do paciente como parte do manejo de epilepsia ou outra condição neurológica, o sofrimento em sessão muitas vezes gira menos em torno do fármaco em si e mais em torno da vida organizada ao redor do risco de crises, dependência de terceiros e restrições cotidianas. Isso pode se expressar como vergonha, perda de autonomia, medo de sair sozinho ou tensão com familiares e equipe médica. Se o terapeuta atribui tudo ao medicamento, corre o risco de subestimar o impacto subjetivo da doença de base e do tratamento prolongado sobre identidade e vínculo."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão pode ganhar um tom de maior sonolência, fala mais lenta, latência aumentada para responder e menor iniciativa associativa. Isso pode ser confundido com retraimento depressivo, exaustão por noites ruins, efeito de outras medicações sedativas ou recuperação de uma crise convulsiva recente. Vale observar se a lentificação aparece como mudança de baseline, se varia conforme o horário da sessão e se o paciente a descreve como “corpo pesado” ou “mente mais devagar”, porque essa distinção ajuda a não ler automaticamente como piora psíquica do quadro de base.

Cognição e atenção: Alguns pacientes referem dificuldade para manter foco, esquecer trechos de conversa, perder o fio do raciocínio ou sentir o pensamento menos ágil. Na sessão, isso pode aparecer como necessidade de repetição, empobrecimento narrativo ou menor capacidade de elaboração, mas também pode decorrer de ansiedade, crises epiléticas, privação de sono, dor crônica ou sobrecarga de vida. A discriminação clínica ganha precisão quando se acompanha a relação temporal entre essas queixas, mudanças recentes no tratamento e flutuações do funcionamento fora do consultório.

Humor e reatividade: Pode haver redução de energia, menor vivacidade afetiva e irritabilidade inespecífica, o que às vezes se mistura com frustração por limitações impostas pela condição neurológica de base. Em sessão, o terapeuta pode notar menos acesso afetivo ou menor reatividade emocional, mas isso não equivale necessariamente a depressão nem a efeito direto do medicamento. Eventos de vida, medo de novas crises, restrições na autonomia e adesão irregular podem produzir apresentação semelhante, por isso convém situar a mudança no contexto mais amplo do período.

Adesão e rotina: Como costuma ser usado em tratamento contínuo, a forma como o paciente organiza horários, lida com esquecimento e interpreta benefícios e incômodos do tratamento tem peso clínico importante. Faltas, uso irregular e ajustes feitos por conta própria podem aparecer indiretamente como oscilação de alerta, piora funcional ou narrativa confusa sobre o que mudou e quando mudou. Na sessão, mais do que checar tecnicamente o esquema, interessa mapear se há abandono silencioso, ambivalência com o tratamento ou dificuldade prática de sustentar a rotina.

Carga do tratamento: Quando o fenobarbital entra na vida do paciente como parte do manejo de epilepsia ou outra condição neurológica, o sofrimento em sessão muitas vezes gira menos em torno do fármaco em si e mais em torno da vida organizada ao redor do risco de crises, dependência de terceiros e restrições cotidianas. Isso pode se expressar como vergonha, perda de autonomia, medo de sair sozinho ou tensão com familiares e equipe médica. Se o terapeuta atribui tudo ao medicamento, corre o risco de subestimar o impacto subjetivo da doença de base e do tratamento prolongado sobre identidade e vínculo.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Fenobarbital é um barbitúrico usado principalmente como anticonvulsivante e, em alguns contextos, como sedativo. No consultório de terapia, tende a aparecer mais como parte do tratamento de epilepsia ou de quadros neurológicos crônicos do que como psicofármaco de uso corrente. Mudanças subjetivas podem surgir nos primeiros dias e semanas após início ou retomada, sobretudo em alerta, velocidade de pensamento, disposição e sono; com uso contínuo, o foco costuma se deslocar para adaptação da rotina, adesão e impacto funcional. O ponto central na sessão é diferenciar lentificação e sonolência relacionadas ao tratamento de humor deprimido, desmotivação, privação de sono, crises convulsivas recentes ou uso irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso parece vir como um peso no corpo e na atenção ou combina mais com tristeza, desânimo e perda de interesse? , Esses lapsos de memória e dificuldade de foco aparecem de modo mais constante ao longo dos dias ou pioram em períodos específicos, como depois de noites ruins, crises, estresse ou mudanças na rotina? , Desde que esse tratamento entrou na sua rotina, o que mudou mais: sua disposição para viver as coisas, sua velocidade para pensar ou sua confiança para sair e tocar a vida? , Quando você falha, atrasa ou muda por conta própria a forma de tomar a medicação, percebe alguma diferença clara no seu corpo, no seu alerta ou no seu funcionamento no dia seguinte? , O que você sente como mais limitante hoje: o efeito de ficar mais devagar, o medo de ter uma crise ou a sensação de que sua vida passou a girar em torno do tratamento?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- Identificado ou com prejuízo funcional novo em atividades básicas
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se houve mudança clínica ou dificuldade de tolerabilidade
- Quando surgem queixas cognitivas persistentes que interferem no trabalho
- estudo ou condução da própria rotina
- pode valer comunicar o médico para situar o impacto funcional e a cronologia dessas mudanças
- Quando o paciente relata uso irregular
- esquecimentos frequentes ou interrupções por conta própria
- pode valer contato com o médico assistente porque isso pode confundir a leitura clínica e aumentar instabilidade do quadro de base
- Quando aparecem rebaixamento importante do humor
- irritabilidade incomum ou retraimento que não se explicam bem por eventos de vida
- pode valer alinhar com o médico para avaliação conjunta da evolução clínica
- Quando há relato de crise convulsiva recente
- aumento de frequência de crises ou sinais de pior controle do quadro neurológico

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicação com o médico assistente para atualização do acompanhamento

Vermelho: tratar como urgência

- Rebaixamento importante do nível de consciência
- fala muito arrastada
- dificuldade de se manter acordado ou confusão acentuada durante a sessão.: Interromper o enquadre habitual
- avaliar segurança imediata e acionar atendimento médico no mesmo dia
- com rede de apoio e emergência se necessário
- Relato de crise convulsiva em curso recente com recuperação incompleta
- repetição de crises em curto intervalo ou estado pós-crise com confusão persistente na sessão.: Priorizar segurança
- acionar suporte médico imediato e orientar busca de avaliação urgente conforme a gravidade observada
- Ideação suicida com intenção
- plano ou perda importante de controle associada a rebaixamento do humor ou desesperança marcantes.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

O foco clínico é separar lentificação e sonolência do tratamento da carga subjetiva e funcional de viver com risco de crises e adesão irregular.

036 LACOSAMIDA

Substância: Lacosamida.

Nomes Comerciais: Lakos, Lacosamida, Seizla, Osamy, Lacotem, Vimpat, Lapsu

Uso comum

- A lacosamida é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsia e, no consultório de terapia, costuma aparecer menos pelo fármaco em si do que pelo contexto de conviver com crises, exames, restrições e medo de recorrência. Quando iniciada ou ajustada, mudanças subjetivas como tontura, lentificação, sonolência ou instabilidade podem surgir nos primeiros dias a poucas semanas; se persistem, oscilam ou levam a faltas e evitação, isso ganha relevância clínica. O ponto central na sessão é discriminar se a queda de energia, a insegurança e a retração decorrem mais do tratamento, da própria condição neurológica, de privação de sono, de outras medicações ou do impacto emocional de viver sob risco de nova crise.

O paciente pode relatar

- **"Lentificação e atenção:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer sensação de cabeça mais lenta, dificuldade de encontrar palavras, atenção menos sustentada ou maior esforço para acompanhar raciocínios. Isso pode aparecer como pausas mais longas, perda do fio da narrativa ou necessidade de retomadas frequentes, mas também pode se confundir com fadiga, ansiedade elevada, pós-crise, privação de sono ou uso concomitante de outros anticonvulsivantes e sedativos. Vale observar se houve mudança nítida em relação à baseline e se o padrão é contínuo ou varia conforme horário, sono e proximidade de crises.

Tontura e instabilidade: Alguns pacientes descrevem tontura, sensação de desequilíbrio ou insegurança corporal, às vezes com impacto direto em deslocamentos, trabalho e autonomia. Na sessão, isso pode aparecer como cautela excessiva ao se mover, receio de sair sozinho ou aumento de evitação, o que facilmente se mistura a ansiedade antecipatória, medo de nova crise ou perda de confiança após quedas prévias. A discriminação clínica ganha força quando se explora a relação temporal entre o sintoma, mudanças recentes no tratamento, episódios de crise e contextos específicos do dia a dia.

Sonolência e ritmo: Sonolência diurna, cansaço e redução do ritmo podem alterar o acesso afetivo e a produtividade da sessão, às vezes parecendo desinvestimento ou piora depressiva. Em outros casos, o paciente mantém interesse e vínculo, mas chega mais lento, bocejando, com menor tolerância a tarefas cognitivas ou com rotina desorganizada pelo sono. Convém não atribuir isso de imediato ao medicamento: crises noturnas, sono fragmentado, comorbidades clínicas, dor e sobrecarga de vida podem produzir quadro semelhante, e adesão irregular também pode gerar dias muito diferentes entre si.

Humor e retração: Embora a lacosamida não seja tipicamente procurada por efeitos psíquicos específicos, o paciente pode chegar mais retraído, frustrado ou desanimado em torno das limitações impostas pela epilepsia e pelo tratamento contínuo. O risco clínico é ler todo fechamento como depressão primária ou, no extremo oposto, reduzir sofrimento psíquico legítimo a um efeito colateral inespecífico. Na prática, ajuda observar se o humor piora junto com perdas funcionais, medo de crises, restrições de direção e trabalho, ou se há uma mudança mais ampla e sustentada do tônus afetivo.

Adesão e rotina: A adesão pode oscilar silenciosamente quando o paciente associa o remédio a mal-estar, sente pouca margem para falar sobre isso ou tenta testar sozinho se está melhor sem ele. Na sessão, isso às vezes aparece indiretamente como narrativa confusa sobre horários, esquecimento frequente, vergonha de admitir interrupções ou explicações vagas para dias muito diferentes entre si. Como a irregularidade pode se confundir com piora do quadro de base ou com efeitos atribuídos ao medicamento, vale mapear a consistência da rotina sem assumir má-fé nem transformar a sessão em checagem farmacológica."

O que observar em sessão

- **Lentificação e atenção:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer sensação de cabeça mais lenta, dificuldade de encontrar palavras, atenção menos sustentada ou maior esforço para acompanhar raciocínios. Isso pode aparecer como pausas mais longas, perda do fio da narrativa ou necessidade de retomadas frequentes, mas também pode se confundir com fadiga, ansiedade elevada, pós-crise, privação de sono ou uso concomitante de outros anticonvulsivantes e sedativos. Vale observar se houve mudança nítida em relação à baseline e se o padrão é contínuo ou varia conforme horário, sono e proximidade de crises.

Tontura e instabilidade: Alguns pacientes descrevem tontura, sensação de desequilíbrio ou insegurança corporal, às vezes com impacto direto em deslocamentos, trabalho e autonomia. Na sessão, isso pode aparecer como cautela excessiva ao se mover, receio de sair sozinho ou aumento de evitação, o que facilmente se mistura a ansiedade antecipatória, medo de nova crise ou perda de confiança após quedas prévias. A discriminação clínica ganha força quando se explora a relação temporal entre o sintoma, mudanças recentes no tratamento, episódios de crise e contextos específicos do dia a dia.

Sonolência e ritmo: Sonolência diurna, cansaço e redução do ritmo podem alterar o acesso afetivo e a produtividade da sessão, às vezes parecendo desinvestimento ou piora depressiva. Em outros casos, o paciente mantém interesse e vínculo, mas chega mais lento, bocejando, com menor tolerância a tarefas cognitivas ou com rotina desorganizada pelo sono. Convém não atribuir isso de imediato ao medicamento: crises noturnas, sono fragmentado, comorbidades clínicas, dor e sobrecarga de vida podem produzir quadro semelhante, e adesão irregular também pode gerar dias muito diferentes entre si.

Humor e retração: Embora a lacosamida não seja tipicamente procurada por efeitos psíquicos específicos, o paciente pode chegar mais retraído, frustrado ou desanimado em torno das limitações impostas pela epilepsia e pelo tratamento contínuo. O risco clínico é ler todo fechamento como depressão primária ou, no extremo oposto, reduzir sofrimento psíquico legítimo a um efeito colateral inespecífico. Na prática, ajuda observar se o humor piora junto com perdas funcionais, medo de crises, restrições de direção e trabalho, ou se há uma mudança mais ampla e sustentada do tônus afetivo.

Adesão e rotina: A adesão pode oscilar silenciosamente quando o paciente associa o remédio a mal-estar, sente pouca margem para falar sobre isso ou tenta testar sozinho se está melhor sem ele. Na sessão, isso às vezes aparece indiretamente como narrativa confusa sobre horários, esquecimento frequente, vergonha de admitir interrupções ou explicações vagas para dias muito diferentes entre si. Como a irregularidade pode se confundir com piora do quadro de base ou com efeitos atribuídos ao medicamento, vale mapear a consistência da rotina sem assumir má-fé nem transformar a sessão em checagem farmacológica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A lacosamida é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsia e, no consultório de terapia, costuma aparecer menos pelo fármaco em si do que pelo contexto de conviver com crises, exames, restrições e medo de recorrência. Quando iniciada ou ajustada, mudanças subjetivas como tontura, lentificação, sonolência ou instabilidade podem surgir nos primeiros dias a poucas semanas; se persistem, oscilam ou levam a faltas e evitação, isso ganha relevância clínica. O ponto central na sessão é discriminar se a queda de energia, a insegurança e a retração decorrem mais do tratamento, da própria condição neurológica, de privação de sono, de outras medicações ou do impacto emocional de viver sob risco de nova crise.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso parece constante ao longo do dia ou aparece em períodos mais específicos? , Essa tontura ou instabilidade vem junto de medo de ter uma crise, ou ela aparece mesmo quando você está emocionalmente mais tranquilo? , Nos dias em que você se percebe mais travado para pensar ou falar, seu sono e sua rotina estavam parecidos com os outros dias ou houve algo diferente? , Esse afastamento das atividades tem mais a ver com desânimo e perda de interesse, ou com receio de passar mal, cair ou ter uma crise fora de casa? , Quando sua semana fica muito diferente da anterior, isso costuma acompanhar mudanças no sono, crises, estresse ou alguma quebra na rotina de tomar a medicação?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- evitar sair sozinho ou reduzir muito a funcionalidade por tontura
- instabilidade ou sonolência
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o peso desses sintomas no tratamento atual
- Quando surgem lentificação cognitiva ou dificuldade de linguagem claramente novas e persistentes em relação à baseline
- pode valer comunicar o médico para diferenciar efeito do tratamento
- pós-crise ou outra intercorrência clínica
- Quando a sessão sugere adesão irregular
- interrupções por conta própria ou uso muito inconsistente por desconforto
- pode valer contato com o médico assistente porque isso pode confundir a leitura clínica e aumentar vulnerabilidade a crises
- Quando há piora importante do humor
- retração acentuada ou desesperança após início recente ou mudança no tratamento
- pode valer alinhar com o médico para avaliação conjunta do contexto clínico e temporal
- Quando o paciente relata quedas
- quase quedas ou insegurança corporal crescente
- especialmente se isso altera trabalho e deslocamento

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicar o médico pela repercussão funcional e pelo risco de acidentes

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente chega muito confuso
- marcadamente desorganizado
- com fala arrastada incomum
- dificuldade importante para se manter em pé ou rebaixamento evidente do nível de alerta.: Interromper o trabalho habitual da sessão e acionar avaliação médica no mesmo dia
- com rede de apoio e emergência se necessário
- Há relato de queda com ferimento
- episódio recente compatível com crise seguido de recuperação incompleta
- ou piora neurológica aguda percebida na sessão.: Priorizar segurança imediata e encaminhar para avaliação médica urgente no mesmo dia
- acionando acompanhante ou emergência conforme o contexto

Frase clínica

O foco clínico costuma ser separar efeito subjetivo do tratamento, impacto das crises e retração por medo de recorrência.

037 LAMOTRIGINA

Substância: Lamotrigina.

Nomes Comerciais: Lamotrigina, Lamictal, Neural, Lamitor Cd, Forlut

Uso comum

- A lamotrigina é um anticonvulsivante também usado como estabilizador do humor, mais frequentemente encontrado em pacientes com transtorno bipolar, sobretudo quando o foco clínico é depressão bipolar e prevenção de novas oscilações. No consultório, a leitura costuma exigir paciência: mudanças terapêuticas tendem a ser graduais ao longo de algumas semanas, e o início do uso ou retomadas após interrupção podem coincidir com desconfortos inespecíficos que confundem a linha de base. O ponto central na sessão é diferenciar melhora progressiva de humor e estabilidade de uma ativação atípica, além de acompanhar adesão, interrupções e o surgimento de sinais físicos novos, especialmente nas primeiras semanas.

O paciente pode relatar

- **"Humor depressivo:** Quando a lamotrigina está associada a alguma resposta clínica, o terapeuta pode notar redução gradual de desesperança, maior acesso afetivo e retomada de iniciativa sem a aceleração típica de uma virada de humor. Essa melhora costuma ser mais lenta do que o desejo do paciente e pode ser confundida com alívio por eventos de vida, férias, reconciliações ou simples oscilação espontânea do quadro. Também vale considerar que frustração com a lentidão percebida pode levar a leituras precipitadas de “não está fazendo nada” e favorecer uso irregular sem que isso apareça de imediato.

Ativação atípica: Embora o objetivo clínico muitas vezes seja estabilização, às vezes a sessão traz aumento incomum de energia, redução importante da necessidade de sono, fala mais acelerada, expansividade ou irritabilidade nova. Nesses casos, o desafio não é assumir causalidade, mas distinguir uma melhora legítima do humor de uma mudança de estado que foge ao baseline do paciente. Estressores positivos, uso concomitante de antidepressivos, substâncias e história bipolar prévia podem confundir bastante essa leitura.

Adesão e interrupções: A lamotrigina pede atenção especial a pausas, esquecimentos repetidos e retomadas por conta própria, porque o paciente pode minimizar interrupções como detalhe sem relevância clínica. Na sessão, isso aparece como resposta errática, oscilação difícil de entender ou narrativa vaga sobre “tomar quando lembra”. O terapeuta ganha muito quando localiza temporalmente falhas de uso em relação a piora, melhora ou aparecimento de desconfortos, sem transformar a conversa em checagem farmacológica.

Sinais cutâneos: Um ponto específico desta substância é o aparecimento de alterações de pele nas primeiras semanas, às vezes acompanhadas de mal-estar, febre ou lesões em mucosas. O paciente pode trazer isso como algo “alérgico”, banalizar por já ter pele sensível ou nem relacionar ao período de início do tratamento. Em sessão, importa menos nomear o quadro e mais reconhecer a combinação entre início recente e sinais físicos novos que justificam contato médico rápido.

Cognição e ritmo: Parte dos pacientes descreve sensação de lentificação, dificuldade de encontrar palavras, atenção menos fluida ou cansaço subjetivo, enquanto outros se percebem mais organizados à medida que o humor estabiliza. Na sessão, isso pode alterar a velocidade associativa, a capacidade de elaboração e a tolerância a tarefas entre sessões. O risco de confusão é alto: privação de sono, depressão em curso, ansiedade, outras medicações e sobrecarga de vida podem produzir apresentações muito parecidas.

Sono e estabilidade: Mudanças no sono ajudam a ler o conjunto: dormir melhor com mais regularidade pode acompanhar estabilização, enquanto redução acentuada da necessidade de sono com energia preservada pede outra hipótese. Também pode haver insônia inespecífica no início ou sono fragmentado por ansiedade, sem que isso indique necessariamente mudança de humor. Observar o padrão ao longo de dias, e não apenas a noite anterior, costuma ser mais útil do que tomar o sintoma isoladamente."

O que observar em sessão

- **Humor depressivo:** Quando a lamotrigina está associada a alguma resposta clínica, o terapeuta pode notar redução gradual de desesperança, maior acesso afetivo e retomada de iniciativa sem a aceleração típica de uma virada de humor. Essa melhora costuma ser mais lenta do que o desejo do paciente e pode ser confundida com alívio por eventos de vida, férias, reconciliações ou simples oscilação espontânea do quadro. Também vale considerar que frustração com a lentidão percebida pode levar a leituras precipitadas de “não está fazendo nada” e favorecer uso irregular sem que isso apareça de imediato.

Ativação atípica: Embora o objetivo clínico muitas vezes seja estabilização, às vezes a sessão traz aumento incomum de energia, redução importante da necessidade de sono, fala mais acelerada, expansividade ou irritabilidade nova. Nesses casos, o desafio não é assumir causalidade, mas distinguir uma melhora legítima do humor de uma mudança de estado que foge ao baseline do paciente. Estressores positivos, uso concomitante de antidepressivos, substâncias e história bipolar prévia podem confundir bastante essa leitura.

Adesão e interrupções: A lamotrigina pede atenção especial a pausas, esquecimentos repetidos e retomadas por conta própria, porque o paciente pode minimizar interrupções como detalhe sem relevância clínica. Na sessão, isso aparece como resposta errática, oscilação difícil de entender ou narrativa vaga sobre “tomar quando lembra”. O terapeuta ganha muito quando localiza temporalmente falhas de uso em relação a piora, melhora ou aparecimento de desconfortos, sem transformar a conversa em checagem farmacológica.

Sinais cutâneos: Um ponto específico desta substância é o aparecimento de alterações de pele nas primeiras semanas, às vezes acompanhadas de mal-estar, febre ou lesões em mucosas. O paciente pode trazer isso como algo “alérgico”, banalizar por já ter pele sensível ou nem relacionar ao período de início do tratamento. Em sessão, importa menos nomear o quadro e mais reconhecer a combinação entre início recente e sinais físicos novos que justificam contato médico rápido.

Cognição e ritmo: Parte dos pacientes descreve sensação de lentificação, dificuldade de encontrar palavras, atenção menos fluida ou cansaço subjetivo, enquanto outros se percebem mais organizados à medida que o humor estabiliza. Na sessão, isso pode alterar a velocidade associativa, a capacidade de elaboração e a tolerância a tarefas entre sessões. O risco de confusão é alto: privação de sono, depressão em curso, ansiedade, outras medicações e sobrecarga de vida podem produzir apresentações muito parecidas.

Sono e estabilidade: Mudanças no sono ajudam a ler o conjunto: dormir melhor com mais regularidade pode acompanhar estabilização, enquanto redução acentuada da necessidade de sono com energia preservada pede outra hipótese. Também pode haver insônia inespecífica no início ou sono fragmentado por ansiedade, sem que isso indique necessariamente mudança de humor. Observar o padrão ao longo de dias, e não apenas a noite anterior, costuma ser mais útil do que tomar o sintoma isoladamente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A lamotrigina é um anticonvulsivante também usado como estabilizador do humor, mais frequentemente encontrado em pacientes com transtorno bipolar, sobretudo quando o foco clínico é depressão bipolar e prevenção de novas oscilações. No consultório, a leitura costuma exigir paciência: mudanças terapêuticas tendem a ser graduais ao longo de algumas semanas, e o início do uso ou retomadas após interrupção podem coincidir com desconfortos inespecíficos que confundem a linha de base. O ponto central na sessão é diferenciar melhora progressiva de humor e estabilidade de uma ativação atípica, além de acompanhar adesão, interrupções e o surgimento de sinais físicos novos, especialmente nas primeiras semanas.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está melhor, isso veio como uma melhora gradual do peso depressivo ou como uma mudança mais brusca, com energia acima do seu habitual? , Nessas últimas semanas, você tem precisado dormir menos e ainda assim se sente inteiro no dia seguinte, ou o sono piorou mas com cansaço e irritação? , Essas oscilações começaram mesmo mantendo uma rotina parecida, ou coincidiram com dias em que você esqueceu, interrompeu ou retomou a medicação? , Essa dificuldade de atenção e de encontrar palavras aparece o tempo todo ou principalmente quando você está mais ansioso, cansado ou com o humor mais baixo? , Você percebe essa energia maior como algo que ampliou sua clareza e seu autocontrole, ou como algo que deixou você mais acelerado, impulsivo ou diferente do seu jeito usual? , Desde que começou ou retomou o uso, apareceu alguma alteração de pele, ferida na boca, febre ou mal-estar junto com essas mudanças?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta melhora muito parcial após algumas semanas
- sem mudança consistente na linha de base depressiva
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar a evolução observada em sessão
- Quando surgem pausas frequentes
- retomadas por conta própria ou uso muito irregular
- pode valer comunicar o médico assistente porque isso dificulta a leitura clínica e pode aumentar risco na reintrodução
- Quando a sessão passa a mostrar redução importante da necessidade de sono
- aceleração
- expansividade ou irritabilidade fora do padrão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para avaliar possível mudança de estado de humor
- Quando o paciente menciona alteração de pele recente
- sobretudo nas primeiras semanas ou junto de febre
- mal-estar ou lesões em mucosas
- pode valer contato médico em curto prazo pela necessidade de avaliação clínica
- Quando há queixa cognitiva persistente que interfere no trabalho terapêutico e na funcionalidade

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicar o médico para diferenciar efeito do tratamento
- quadro de base e fatores concomitantes

Vermelho: tratar como urgência

- Início recente ou retomada do uso acompanhado de manchas na pele
- bolhas
- descamação
- feridas na boca ou nos olhos
- especialmente com febre ou mal-estar.: Orientar avaliação médica no mesmo dia; se houver acometimento importante de mucosas
- febre ou piora rápida
- acionar emergência e rede de apoio
- A sessão mostra virada abrupta para energia muito aumentada
- fala pressionada
- pouca necessidade de sono
- impulsividade ou grandiosidade fora do padrão do paciente.: Contatar o psiquiatra no mesmo dia e avaliar necessidade de apoio familiar e manejo de risco conforme o grau de desorganização e exposição
- Aparecem ideação suicida em intensificação
- desesperança aguda ou planejamento
- sobretudo em contexto de início de tratamento ou mudança recente do estado de humor.: Fazer manejo de risco no mesmo atendimento
- acionar psiquiatra e rede de apoio e encaminhar para emergência quando necessário

Frase clínica

Na terapia, o foco com lamotrigina é ler melhora gradual versus mudança atípica de humor, sem perder de vista adesão e sinais físicos precoces.

038 LEVETIRACETAM

Substância: Levetiracetam.

Nomes Comerciais: Levetiracetam, Antara, Spark, Antara IV, Spark Xr, Antara Xr, Lecza Xr, Tam, Tam Xr, Veepi, Frontlev, Etira Injetável, Etira Xr, Etira, Iludral, Keppra, Keppra Xr

Uso comum

- Levetiracetam é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsia e, no consultório de terapia, costuma aparecer mais pelo impacto subjetivo do tratamento contínuo do que por um efeito psicotrópico buscado. Quando há mudanças relacionadas ao início ou ajuste, elas tendem a surgir nos primeiros dias a poucas semanas; depois, o foco costuma se deslocar para estabilidade do humor, irritabilidade, fadiga, sono e adesão. Na sessão, o ponto central é diferenciar mudanças comportamentais ligadas ao medicamento de efeitos da própria epilepsia, privação de sono, medo de novas crises, restrições na rotina e sobrecarga de viver sob vigilância clínica.

O paciente pode relatar

- **"Irritabilidade:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter mais impaciência, reatividade, pavio curto ou sensação de estar "mais áspero" nas interações, às vezes sem tristeza proporcional. Isso pode ser percebido no tom, na tolerância à frustração e na forma de narrar conflitos recentes. A leitura pode se confundir com estresse acumulado, privação de sono, medo de novas crises, conflitos familiares em torno de autonomia ou traços prévios de personalidade; por isso, vale comparar com a linha de base e com a proximidade temporal de mudanças no tratamento.

Humor e retraimento: Alguns pacientes ficam mais desanimados, menos disponíveis afetivamente ou mais isolados, o que pode parecer piora depressiva, mas nem sempre vem acompanhado da mesma qualidade de culpa, desesperança ou autodepreciação do episódio depressivo típico. Na sessão, pode haver menor espontaneidade, menos investimento associativo e redução do interesse por atividades antes preservadas. Também aqui entram confundidores importantes: impacto subjetivo do diagnóstico, limitações funcionais após crises, vergonha social, luto por perda de autonomia e outras medicações em uso.

Sono e energia: Cansaço, sonolência ou sensação de lentificação podem aparecer e alterar o ritmo da sessão, com menor fôlego para elaboração e mais dificuldade de sustentar atenção. Em outros casos, o sono já vinha fragmentado pelo medo de convulsionar, por rotina desorganizada ou por comorbidades clínicas, o que torna a atribuição menos direta. A discriminação clínica costuma depender de observar se a queda de energia surgiu junto com a medicação ou se acompanha uma piora global do humor, aumento de crises ou mudanças relevantes de vida.

Cognição na sessão: O paciente pode descrever mais dificuldade para encontrar palavras, manter o fio da conversa ou recuperar detalhes recentes, e isso às vezes aparece como empobrecimento associativo ou maior necessidade de repetição em sessão. Nem sempre isso aponta para efeito do medicamento: crises epiléticas, ansiedade antecipatória, noites ruins e sobrecarga emocional também reduzem desempenho cognitivo percebido. Vale observar se a oscilação é nova, persistente e fora do padrão habitual do paciente, em vez de concluir por causalidade única.

Adesão e rotina: Como se trata de tratamento contínuo, esquecimentos, uso irregular ou interrupções silenciosas podem aparecer menos como tema médico e mais como ambivalência, cansaço de ser paciente, negação da condição ou desejo de retomar sensação de normalidade. Na sessão, isso pode surgir em relatos vagos sobre horários, minimização de falhas ou oscilação entre hipercontrole e abandono. A leitura se complica porque efeitos subjetivos desagradáveis, medo de dependência, dificuldades práticas e dinâmica familiar podem pesar tanto quanto a compreensão da necessidade do tratamento."

O que observar em sessão

- **Irritabilidade:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter mais impaciência, reatividade, pavor curto ou sensação de estar “mais áspero” nas interações, às vezes sem tristeza proporcional. Isso pode ser percebido no tom, na tolerância à frustração e na forma de narrar conflitos recentes. A leitura pode se confundir com estresse acumulado, privação de sono, medo de novas crises, conflitos familiares em torno de autonomia ou traços prévios de personalidade; por isso, vale comparar com a linha de base e com a proximidade temporal de mudanças no tratamento.

Humor e retraimento: Alguns pacientes ficam mais desanimados, menos disponíveis afetivamente ou mais isolados, o que pode parecer piora depressiva, mas nem sempre vem acompanhado da mesma qualidade de culpa, desesperança ou autodepreciação do episódio depressivo típico. Na sessão, pode haver menor espontaneidade, menos investimento associativo e redução do interesse por atividades antes preservadas. Também aqui entram confundidores importantes: impacto subjetivo do diagnóstico, limitações funcionais após crises, vergonha social, luto por perda de autonomia e outras medicações em uso.

Sono e energia: Cansaço, sonolência ou sensação de lentificação podem aparecer e alterar o ritmo da sessão, com menor fôlego para elaboração e mais dificuldade de sustentar atenção. Em outros casos, o sono já vinha fragmentado pelo medo de convulsionar, por rotina desorganizada ou por comorbidades clínicas, o que torna a atribuição menos direta. A discriminação clínica costuma depender de observar se a queda de energia surgiu junto com a medicação ou se acompanha uma piora global do humor, aumento de crises ou mudanças relevantes de vida.

Cognição na sessão: O paciente pode descrever mais dificuldade para encontrar palavras, manter o fio da conversa ou recuperar detalhes recentes, e isso às vezes aparece como empobrecimento associativo ou maior necessidade de repetição em sessão. Nem sempre isso aponta para efeito do medicamento: crises epiléticas, ansiedade antecipatória, noites ruins e sobrecarga emocional também reduzem desempenho cognitivo percebido. Vale observar se a oscilação é nova, persistente e fora do padrão habitual do paciente, em vez de concluir por causalidade única.

Adesão e rotina: Como se trata de tratamento contínuo, esquecimentos, uso irregular ou interrupções silenciosas podem aparecer menos como tema médico e mais como ambivalência, cansaço de ser paciente, negação da condição ou desejo de retomar sensação de normalidade. Na sessão, isso pode surgir em relatos vagos sobre horários, minimização de falhas ou oscilação entre hipercontrole e abandono. A leitura se complica porque efeitos subjetivos desagradáveis, medo de dependência, dificuldades práticas e dinâmica familiar podem pesar tanto quanto a compreensão da necessidade do tratamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Levetiracetam é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsia e, no consultório de terapia, costuma aparecer mais pelo impacto subjetivo do tratamento contínuo do que por um efeito psicotrópico buscado. Quando há mudanças relacionadas ao início ou ajuste, elas tendem a surgir nos primeiros dias a poucas semanas; depois, o foco costuma se deslocar para estabilidade do humor, irritabilidade, fadiga, sono e adesão. Na sessão, o ponto central é diferenciar mudanças comportamentais ligadas ao medicamento de efeitos da própria epilepsia, privação de sono, medo de novas crises, restrições na rotina e sobrecarga de viver sob vigilância clínica.

Perguntas úteis

- "Essas mudanças de irritação ou impaciência começaram perto de alguma mudança no tratamento, ou vieram crescendo junto com estresse, noites ruins ou conflitos específicos? , Quando você se sente mais para baixo ou mais afastado, isso parece tristeza e desesperança como em outros momentos da sua vida, ou mais uma sensação de estar sem disposição e sem paciência? , Nos dias em que você se percebe mais lento ou cansado, isso melhora em alguns horários ou acompanha uma piora geral do sono, do humor e da rotina? , Essa dificuldade de atenção e memória aparece de modo novo desde o tratamento, ou você reconhece o mesmo padrão depois de crises, ansiedade alta ou noites mal dormidas? , Quando você falha no uso, isso costuma acontecer por esquecimento prático, por incômodo com como você se sente, ou por momentos em que pensa que talvez não precise mais?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a apresentar irritabilidade marcada
- explosões incomuns ou mudança comportamental sustentada fora da sua linha de base
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar temporalidade e impacto funcional
- Quando surgem desânimo importante
- retraimento ou piora consistente do humor nas primeiras semanas após início ou mudança recente do tratamento
- pode valer comunicar para avaliação conjunta da hipótese medicamentosa versus evolução do quadro
- Quando a sonolência
- fadiga ou lentificação começam a comprometer trabalho
- estudo
- direção ou a própria participação em sessão
- pode valer contato com o médico para registrar impacto funcional relevante
- Quando o paciente relata uso irregular
- interrupções por conta própria ou ambivalência importante em manter o tratamento
- pode valer alinhar com o médico assistente porque a adesão interfere diretamente na estabilidade clínica
- Quando aparecem queixas cognitivas novas e persistentes

Amarelo: alinhar em breve

- com prejuízo claro no cotidiano ou diferença nítida em relação ao baseline
- pode valer comunicar para melhor discriminação clínica

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecimento de ideação suicida nova ou nitidamente intensificada
- sobretudo quando vem junto de retraimento
- desesperança ou mudança recente no tratamento.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar psiquiatra e rede de apoio e encaminhar para emergência quando necessário
- Mudança abrupta de comportamento com agitação intensa
- confusão
- fala muito desorganizada ou rebaixamento importante do nível de alerta durante a sessão.: Interromper o enquadre habitual
- avaliar segurança imediata e acionar atendimento médico urgente ou emergência conforme o quadro

Frase clínica

O foco clínico é separar irritabilidade, fadiga e retraimento ligados ao tratamento da carga subjetiva de viver com epilepsia e da adesão irregular.

039 OXCARBAZEPINA

Substância: Oxcarbazepina.

Nomes Comerciais: Trileptal, Oxcarb, Oxcarbazepina, Oleptal

Uso comum

- Oxcarbazepina é um anticonvulsivante que também pode aparecer no consultório em uso psiquiátrico, sobretudo em quadros com instabilidade de humor, irritabilidade ou impulsividade, além de pacientes que a usam por epilepsia. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta costuma acompanhar tolerabilidade inicial, especialmente sonolência, lentificação, tontura e oscilação de energia; ao longo de 2 a 6 semanas pode ficar mais claro se houve redução de reatividade ou se surgiu embotamento e queda de iniciativa. O ponto central na sessão é diferenciar estabilização útil de sedação, lentificação ou adesão irregular, sem perder de vista sinais físicos que mudam a urgência clínica.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com fala menos espontânea, maior latência de resposta, bocejos, queixa de cansaço ou sensação de estar "mais pesado". Isso pode se confundir com melhora de agitação prévia, piora depressiva, privação de sono ou sobrecarga de rotina. Vale observar se a lentificação apareceu após o início da medicação, se varia ao longo do dia e se o paciente a descreve como alívio da aceleração ou como perda de presença e funcionalidade.

Cognição e clareza: Alguns pacientes referem dificuldade de concentração, sensação de cabeça "nublada", esquecimento recente ou menor agilidade para organizar pensamento e sustentar elaboração. Na sessão, isso pode aparecer como perda do fio, necessidade de repetição ou menor capacidade de simbolização, mas também pode decorrer do próprio quadro de base, de ansiedade alta, crises convulsivas, outras medicações sedativas ou sono ruim. A discriminação clínica ganha precisão quando se compara a linha de base anterior e se mapeia se a oscilação cognitiva acompanha horários de tomada ou dias de adesão irregular.

Humor e reatividade: Quando usada em contexto psiquiátrico, pode coincidir com redução de irritabilidade, impulsividade e explosividade, o que às vezes é vivido como ganho de controle e, em outras, como achatamento ou menor acesso afetivo. O terapeuta pode notar menos escalada emocional e menos urgência nas narrativas, mas isso não equivale automaticamente a melhora global. Convém diferenciar se houve ampliação de capacidade reflexiva ou apenas queda de intensidade às custas de apatia, além de considerar eventos de vida, uso concomitante de outros psicofármacos e flutuações próprias do transtorno de base.

Adesão e oscilação: A adesão irregular pode aparecer menos como confissão espontânea e mais como mudanças abruptas no padrão da sessão: um encontro com mais sedação, outro com maior irritabilidade, tontura ou sensação corporal estranha, sem explicação emocional proporcional. Em pacientes que usam por epilepsia, falhas de uso também podem vir acompanhadas de medo de crise, vergonha ou minimização do risco; em uso psiquiátrico, podem surgir como abandono silencioso por desconforto subjetivo. Vale explorar com cuidado a sequência temporal entre mudanças no estado mental, rotina e uso efetivo, sem assumir causalidade única.

Sinais físicos relevantes: Tontura, instabilidade, náusea, mal-estar e queixas corporais inespecíficas podem atravessar a sessão e ser lidos apressadamente como ansiedade somatizada ou resistência ao tratamento. Em alguns casos, o paciente também menciona dor de cabeça, visão turva, fraqueza ou sensação de estar "estranho" fisicamente, o que merece registro mais atento quando é novo ou progressivo. O ponto clínico não é interpretar esses sinais, mas notar quando o componente físico foge do padrão habitual do paciente, especialmente se vier junto de confusão, sonolência importante ou piora funcional.

Pele e tolerabilidade: Embora não seja o mais frequente no consultório, surgimento de manchas, vermelhidão, coceira ou desconforto cutâneo após o início pode aparecer primeiro na sessão, às vezes minimizado pelo paciente como algo banal. O terapeuta pode encontrar hesitação em relacionar o sintoma ao tratamento, sobretudo quando há medo de "dar trabalho" ou de perder um ganho percebido no humor. Aqui, a tarefa é menos interpretar e mais

reconhecer a mudança corporal recente, situá-la no tempo e avaliar se há progressão ou associação com mal-estar geral."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com fala menos espontânea, maior latência de resposta, bocejos, queixa de cansaço ou sensação de estar “mais pesado”. Isso pode se confundir com melhora de agitação prévia, piora depressiva, privação de sono ou sobrecarga de rotina. Vale observar se a lentificação apareceu após o início da medicação, se varia ao longo do dia e se o paciente a descreve como alívio da aceleração ou como perda de presença e funcionalidade.

Cognição e clareza: Alguns pacientes referem dificuldade de concentração, sensação de cabeça “nublada”, esquecimento recente ou menor agilidade para organizar pensamento e sustentar elaboração. Na sessão, isso pode aparecer como perda do fio, necessidade de repetição ou menor capacidade de simbolização, mas também pode decorrer do próprio quadro de base, de ansiedade alta, crises convulsivas, outras medicações sedativas ou sono ruim. A discriminação clínica ganha precisão quando se compara a linha de base anterior e se mapeia se a oscilação cognitiva acompanha horários de tomada ou dias de adesão irregular.

Humor e reatividade: Quando usada em contexto psiquiátrico, pode coincidir com redução de irritabilidade, impulsividade e explosividade, o que às vezes é vivido como ganho de controle e, em outras, como achatamento ou menor acesso afetivo. O terapeuta pode notar menos escalada emocional e menos urgência nas narrativas, mas isso não equivale automaticamente a melhora global. Convém diferenciar se houve ampliação de capacidade reflexiva ou apenas queda de intensidade às custas de apatia, além de considerar eventos de vida, uso concomitante de outros psicofármacos e flutuações próprias do transtorno de base.

Adesão e oscilação: A adesão irregular pode aparecer menos como confissão espontânea e mais como mudanças abruptas no padrão da sessão: um encontro com mais sedação, outro com maior irritabilidade, tontura ou sensação corporal estranha, sem explicação emocional proporcional. Em pacientes que usam por epilepsia, falhas de uso também podem vir acompanhadas de medo de crise, vergonha ou minimização do risco; em uso psiquiátrico, podem surgir como abandono silencioso por desconforto subjetivo. Vale explorar com cuidado a sequência temporal entre mudanças no estado mental, rotina e uso efetivo, sem assumir causalidade única.

Sinais físicos relevantes: Tontura, instabilidade, náusea, mal-estar e queixas corporais inespecíficas podem atravessar a sessão e ser lidos apressadamente como ansiedade somatizada ou resistência ao tratamento. Em alguns casos, o paciente também menciona dor de cabeça, visão turva, fraqueza ou sensação de estar “estranho” fisicamente, o que merece registro mais atento quando é novo ou progressivo. O ponto clínico não é interpretar esses sinais, mas notar quando o componente físico foge do padrão habitual do paciente, especialmente se vier junto de confusão, sonolência importante ou piora funcional.

Pele e tolerabilidade: Embora não seja o mais frequente no consultório, surgimento de manchas, vermelhidão, coceira ou desconforto cutâneo após o início pode aparecer primeiro na sessão, às vezes minimizado pelo paciente como algo banal. O terapeuta pode encontrar hesitação em relacionar o sintoma ao tratamento, sobretudo quando há medo de “dar trabalho” ou de perder um ganho percebido no humor. Aqui, a tarefa é menos interpretar e mais

reconhecer a mudança corporal recente, situá-la no tempo e avaliar se há progressão ou associação com mal-estar geral.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Oxcarbazepina é um anticonvulsivante que também pode aparecer no consultório em uso psiquiátrico, sobretudo em quadros com instabilidade de humor, irritabilidade ou impulsividade, além de pacientes que a usam por epilepsia. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta costuma acompanhar tolerabilidade inicial, especialmente sonolência, lentificação, tontura e oscilação de energia; ao longo de 2 a 6 semanas pode ficar mais claro se houve redução de reatividade ou se surgiu embotamento e queda de iniciativa. O ponto central na sessão é diferenciar estabilização útil de sedação, lentificação ou adesão irregular, sem perder de vista sinais físicos que mudam a urgência clínica.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso vem como uma calma que ajuda a pensar melhor ou como um apagamento que atrapalha você a estar presente no dia? , Essa dificuldade de concentração parece contínua desde que começou o remédio ou aparece mais em certos horários, em alguns dias, ou quando sua rotina de sono sai do eixo? , A redução da irritabilidade veio junto com mais capacidade de escolher como responder ou com uma sensação de tanto faz, como se o afeto tivesse ficado distante? , Nos dias em que você se percebe muito diferente do seu padrão, houve alguma mudança na rotina de uso, no sono, no estresse ou em outras medicações? , Essas queixas físicas que apareceram agora se parecem com a sua ansiedade habitual ou têm um caráter novo, mais corporal, que você não reconhece do seu padrão? , Essas alterações na pele ou no corpo começaram perto do início do tratamento e estão estáveis, melhorando ou se espalhando?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta sedação
- lentificação ou confusão que começam a comprometer trabalho
- direção
- autocuidado ou participação na própria sessão
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar impacto funcional e temporalidade
- Quando surgem queixas cognitivas novas e persistentes
- com perda clara de clareza mental em relação à linha de base
- pode valer comunicar para diferenciar efeito do tratamento
- evolução do quadro ou combinação com outras medicações
- Quando o paciente relata uso irregular
- interrupções por conta própria ou abandono silencioso por desconforto subjetivo
- pode valer alinhar com o médico assistente para reduzir risco clínico e esclarecer o contexto da adesão
- Quando aparecem tontura importante

Amarelo: alinhar em breve

- fraqueza
- náusea
- confusão ou mal-estar físico novo sem explicação emocional proporcional
- pode valer comunicação mais breve para situar possível relevância clínica
- Quando surgem manchas
- vermelhidão
- coceira ou outras alterações cutâneas recentes após o início
- especialmente se progressivas
- pode valer contato com o médico assistente pela necessidade de avaliação clínica
- Quando
- após algumas semanas
- não há ganho perceptível no alvo clínico e o custo subjetivo parece alto
- pode valer alinhar com o médico assistente para compartilhar observações de sessão e impacto funcional

Vermelho: tratar como urgência

- Confusão acentuada
- sonolência intensa
- fala muito arrastada
- dificuldade de se manter acordado ou de se orientar durante a sessão.: Interromper o trabalho interpretativo
- avaliar segurança imediata
- acionar médico assistente no mesmo dia e considerar rede de apoio ou emergência conforme gravidade
- Alteração cutânea que progride rapidamente ou vem acompanhada de febre
- mal-estar importante
- inchaço ou acometimento de boca e olhos.: Orientar avaliação médica imediata e acionar rede de apoio e serviço de urgência quando necessário
- além de comunicar o médico assistente no mesmo dia
- Ideação suicida emergente ou intensificada
- sobretudo quando coincide com piora global
- agitação incomum
- desesperança abrupta ou mudança recente no tratamento.: Fazer manejo de risco na própria sessão
- acionar rede de apoio e médico assistente no mesmo dia e encaminhar para emergência se houver risco iminente

Frase clínica

O foco é distinguir estabilização útil de sedação, lentificação e sinais físicos novos que mudam a urgência clínica.

040 PERAMPANEL

Substância: Perampanel.

Nomes Comerciais: Fycompa

Uso comum

- Perampanel é um anticonvulsivante usado em epilepsia, geralmente em tratamento contínuo e muitas vezes em combinação com outros fármacos. No consultório de terapia, tende a importar menos a substância isoladamente do que mudanças de irritabilidade, impulsividade, sonolência, lentificação e oscilação do funcionamento após início ou ajuste recente, sobretudo nas primeiras semanas. Quando o uso é irregular, podem surgir piora do bem-estar, mais insegurança e relatos confusos sobre o que decorre da medicação, das crises, do medo de novas crises ou da sobrecarga do tratamento. O ponto central é acompanhar mudança de baseline comportamental e afetivo sem atribuição causal apressada.

O paciente pode relatar

- **"Irritabilidade:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer aumento de irritabilidade, pavor curto, reatividade desproporcional ou sensação de estar mais agressivo do que o habitual. Vale observar se isso aparece como mudança nítida de baseline, com menor tolerância à frustração também no vínculo terapêutico, ou se acompanha estressores recentes, privação de sono, crises epiléticas, uso de outras medicações sedativas ou ativadoras e conflitos prévios já presentes. A leitura pode se confundir quando o paciente descreve apenas "nervosismo", sem conseguir situar se houve mudança temporal após início ou mudança do tratamento.

Impulsividade: Alguns pacientes passam a relatar respostas mais bruscas, discussões repentinas, menor freio inibitório ou atitudes das quais se arrependem depois. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais cortante, menor capacidade de pausar antes de agir ou dificuldade de simbolizar o intervalo entre impulso e ação. Também aqui é fácil confundir com traços prévios, uso de substâncias, sobrecarga familiar, medo de novas crises ou desorganização associada à própria epilepsia, por isso a comparação com o padrão anterior é mais útil do que a busca de uma causa única.

Sonolência e ritmo: Sonolência, cansaço e lentificação podem reduzir a presença psíquica na sessão, empobrecer elaboração e ser lidos apressadamente como retraimento depressivo. Convém observar se o paciente parece mais sonolento em horários específicos, se houve queda recente de energia no cotidiano e se isso coincide com início, ajuste ou combinação com outros medicamentos que também sedam. Quando a fala fica mais lenta e o pensamento menos acessível, a distinção importante é entre efeito inespecífico sobre alerta, piora do humor e exaustão por crises, dor ou noites mal dormidas.

Cognição funcional: Pode haver queixas de atenção, memória recente, dificuldade para organizar tarefas ou sensação de estar "mais devagar". Na sessão, isso se traduz por perda do fio, necessidade de repetição, menor capacidade de acompanhar interpretações mais complexas ou aumento de concretude. Como epilepsia, crises subclínicas, ansiedade antecipatória e polifarmácia também afetam cognição, vale menos nomear o fenômeno e mais mapear quando começou, em que contextos piora e quanto interfere na funcionalidade habitual.

Humor e risco: Mudanças de humor merecem leitura cuidadosa porque podem refletir sofrimento com a doença crônica, restrições de autonomia, medo de convulsões, eventos de vida ou efeito do tratamento. O que chama atenção na sessão não é apenas tristeza, mas irritabilidade intensa, desesperança nova, hostilidade incomum ou surgimento de ideias de morte em alguém cujo padrão anterior era diferente. Se o paciente já tinha vulnerabilidade afetiva, a tarefa clínica é discriminar continuidade do quadro de base de uma inflexão temporal mais abrupta no comportamento e no risco.

Adesão e rotina: Como costuma ser um tratamento prolongado, esquecimentos, uso irregular e abandono silencioso podem aparecer mais como confusão narrativa do que como decisão explícita. O paciente pode atribuir mal-estar ao remédio, às crises ou ao próprio estresse sem conseguir localizar se houve falhas de tomada, mudanças de horário ou interrupções. Na terapia, isso importa porque adesão irregular pode embaralhar a leitura clínica, aumentar insegurança e produzir oscilação do funcionamento que parece "emocional", mas acompanha uma rotina

medicamentosa instável."

O que observar em sessão

- **Irritabilidade:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer aumento de irritabilidade, pavor curto, reatividade desproporcional ou sensação de estar mais agressivo do que o habitual. Vale observar se isso aparece como mudança nítida de baseline, com menor tolerância à frustração também no vínculo terapêutico, ou se acompanha estressores recentes, privação de sono, crises epiléticas, uso de outras medicações sedativas ou ativadoras e conflitos prévios já presentes. A leitura pode se confundir quando o paciente descreve apenas “nervosismo”, sem conseguir situar se houve mudança temporal após início ou mudança do tratamento.

Impulsividade: Alguns pacientes passam a relatar respostas mais bruscas, discussões repentinas, menor freio inibitório ou atitudes das quais se arrependem depois. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais cortante, menor capacidade de pausar antes de agir ou dificuldade de simbolizar o intervalo entre impulso e ação. Também aqui é fácil confundir com traços prévios, uso de substâncias, sobrecarga familiar, medo de novas crises ou desorganização associada à própria epilepsia, por isso a comparação com o padrão anterior é mais útil do que a busca de uma causa única.

Sonolência e ritmo: Sonolência, cansaço e lentificação podem reduzir a presença psíquica na sessão, empobrecer elaboração e ser lidos apressadamente como retraimento depressivo. Convém observar se o paciente parece mais sonolento em horários específicos, se houve queda recente de energia no cotidiano e se isso coincide com início, ajuste ou combinação com outros medicamentos que também sedam. Quando a fala fica mais lenta e o pensamento menos acessível, a distinção importante é entre efeito inespecífico sobre alerta, piora do humor e exaustão por crises, dor ou noites mal dormidas.

Cognição funcional: Pode haver queixas de atenção, memória recente, dificuldade para organizar tarefas ou sensação de estar “mais devagar”. Na sessão, isso se traduz por perda do fio, necessidade de repetição, menor capacidade de acompanhar interpretações mais complexas ou aumento de concretude. Como epilepsia, crises subclínicas, ansiedade antecipatória e polifarmácia também afetam cognição, vale menos nomear o fenômeno e mais mapear quando começou, em que contextos piora e quanto interfere na funcionalidade habitual.

Humor e risco: Mudanças de humor merecem leitura cuidadosa porque podem refletir sofrimento com a doença crônica, restrições de autonomia, medo de convulsões, eventos de vida ou efeito do tratamento. O que chama atenção na sessão não é apenas tristeza, mas irritabilidade intensa, desesperança nova, hostilidade incomum ou surgimento de ideias de morte em alguém cujo padrão anterior era diferente. Se o paciente já tinha vulnerabilidade afetiva, a tarefa clínica é discriminar continuidade do quadro de base de uma inflexão temporal mais abrupta no comportamento e no risco.

Adesão e rotina: Como costuma ser um tratamento prolongado, esquecimentos, uso irregular e abandono silencioso podem aparecer mais como confusão narrativa do que como decisão explícita. O paciente pode atribuir mal-estar ao remédio, às crises ou ao próprio estresse sem conseguir localizar se houve falhas de tomada, mudanças de horário ou interrupções. Na terapia, isso importa porque adesão irregular pode embaralhar a leitura clínica, aumentar insegurança e produzir oscilação do funcionamento que parece “emocional”, mas acompanha uma rotina

medicamentosa instável.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Perampanel é um anticonvulsivante usado em epilepsia, geralmente em tratamento contínuo e muitas vezes em combinação com outros fármacos. No consultório de terapia, tende a importar menos a substância isoladamente do que mudanças de irritabilidade, impulsividade, sonolência, lentificação e oscilação do funcionamento após início ou ajuste recente, sobretudo nas primeiras semanas. Quando o uso é irregular, podem surgir piora do bem-estar, mais insegurança e relatos confusos sobre o que decorre da medicação, das crises, do medo de novas crises ou da sobrecarga do tratamento. O ponto central é acompanhar mudança de baseline comportamental e afetivo sem atribuição causal apressada.

Perguntas úteis

- "Quando você se percebe mais irritado ou explosivo, isso parece surgir do nada ou costuma vir ligado a conflito, frustração, cansaço ou medo de ter uma nova crise? , Essa sensação de estar mais devagar aparece como sono e corpo pesado, ou como desânimo e perda de interesse pelas coisas? , Os episódios em que você reage sem pensar parecem uma intensificação de algo que já existia em você ou pessoas próximas notaram uma mudança mais recente no seu jeito? , Sua dificuldade de atenção e memória é constante ao longo do dia ou piora em horários específicos, depois de noites ruins ou em períodos de maior ansiedade? , Quando seu humor piorou, isso veio junto de mudanças claras na rotina do tratamento, de crises, ou aconteceu mesmo sem nada disso que você consiga identificar? , Nas últimas semanas, houve dias em que você deixou de tomar, tomou em horários muito diferentes ou ficou em dúvida se tinha tomado, e o que mudou no seu funcionamento nesses dias?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta irritabilidade ou agressividade claramente acima do seu padrão
- especialmente com início recente e impacto relacional
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a mudança no contexto do tratamento e do risco comportamental
- Quando sonolência
- lentificação ou dificuldade cognitiva passam a comprometer trabalho
- estudo
- direção ou a própria participação na psicoterapia
- pode valer comunicar o médico para revisão clínica da tolerabilidade global
- Quando surgem ideias de morte
- desesperança nova ou piora importante do humor após mudança recente no tratamento
- pode valer contato com o médico assistente pela necessidade de avaliação mais próxima
- Quando o paciente relata uso irregular
- esquecimentos frequentes ou interrupção por conta própria e a narrativa clínica fica oscilante
- pode valer alinhar com o médico para reduzir confusão na leitura do quadro

Amarelo: alinhar em breve

- Quando familiares ou o próprio paciente descrevem mudança comportamental abrupta
- com impulsividade ou hostilidade incomuns
- pode valer comunicação com o médico para avaliação de segurança e temporalidade do quadro

Vermelho: tratar como urgência

- Ideias de morte com intenção
- plano
- aumento rápido de desesperança ou sensação de que pode perder o controle do próprio comportamento.: Fazer manejo imediato de risco
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- recorrendo à emergência quando necessário
- Agressividade intensa
- ameaça concreta a terceiros ou incapacidade de conter impulsos de forma segura durante ou logo após a sessão.: Priorizar contenção e segurança
- acionar rede de apoio e avaliação médica urgente no mesmo dia
- com emergência se necessário

Frase clínica

O foco é rastrear mudança de baseline em irritabilidade, impulsividade e alerta sem confundir tratamento, crises epiléticas e sobrecarga da doença.

041 PRIMIDONA

Substância: Primidona.

Nomes Comerciais: Primid

Uso comum

- Primidona é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsia e, em alguns contextos, para tremor essencial. No consultório de terapia, tende a aparecer mais como parte do manejo de uma condição neurológica crônica do que como foco principal em si. Nas primeiras semanas e após mudanças recentes no tratamento, vale observar com mais atenção sedação, lentificação, instabilidade subjetiva e impacto funcional; ao longo dos meses, o eixo costuma ser adesão, estigma da doença, medo de crises e reorganização da rotina. O ponto central na sessão é diferenciar efeitos percebidos do tratamento, flutuações da condição de base e sobrecarga de viver sob risco de recorrência de sintomas neurológicos.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer sonolência, fala mais lenta, menor prontidão cognitiva ou sensação de estar mais pesado ao longo do dia. Isso pode se confundir com humor deprimido, privação de sono, uso de outras medicações sedativas ou exaustão por conviver com crises, tremor e restrições funcionais. Vale comparar com a linha de base do paciente, notar se a lentificação é nova ou flutuante e observar se ela compromete atenção, elaboração e presença na sessão.

Cognição funcional: Alguns pacientes descrevem dificuldade para se concentrar, lapsos de memória recente ou sensação de raciocínio menos ágil, especialmente quando tentam retomar trabalho, estudo ou tarefas que exigem precisão. Na sessão, isso pode aparecer como perda do fio narrativo, maior necessidade de repetição ou redução da capacidade de simbolização, mas também pode refletir ansiedade, crises subclínicas, sono ruim ou sobrecarga emocional. A discriminação clínica ganha força quando se investiga o momento de início, a constância ao longo da semana e o quanto isso varia conforme contexto e demanda.

Adesão e ambivalência: Como se trata de um tratamento de uso contínuo em muitos casos, pode surgir ambivalência silenciosa: o paciente quer proteção contra crises ou tremor, mas se ressentido de depender de medicação, teme estigma ou evita tomar regularmente quando se sente bem. No consultório, isso às vezes aparece como narrativa vaga sobre horários, minimização de esquecimentos ou oscilação entre confiança e irritação com o tratamento. Também é fácil confundir piora por adesão irregular com agravamento espontâneo do quadro neurológico ou com efeitos atribuídos genericamente ao remédio.

Ansiedade antecipatória: Mesmo quando a medicação está estável, o medo de uma nova crise, de perder controle em público ou de ser visto como frágil pode organizar boa parte da vida psíquica. O terapeuta pode notar hipervigilância corporal, evitação de deslocamentos, retração social e necessidade de monitorar sinais físicos, o que por vezes parece ansiedade primária, mas pode estar ancorado em experiências reais de imprevisibilidade. Vale situar se a apreensão diminui quando o paciente se sente protegido e previsível ou se segue desproporcional ao contexto, sugerindo outros determinantes clínicos.

Identidade e funcionalidade: Em uso prolongado, o impacto mais relevante muitas vezes não é um efeito isolado, mas a forma como a condição neurológica e seu tratamento reorganizam autonomia, trabalho, direção de vida e autoimagem. Na sessão, podem aparecer vergonha, sensação de limitação, dependência maior da família ou luto pela versão anterior de si, o que pode ser lido apressadamente como depressão isolada. A observação clínica fica mais precisa quando se distingue sofrimento reativo à condição, efeitos percebidos do tratamento e mudanças reais de capacidade funcional no cotidiano."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer sonolência, fala mais lenta, menor prontidão cognitiva ou sensação de estar "mais pesado" ao longo do dia. Isso pode se confundir com humor deprimido, privação de sono, uso de outras medicações sedativas ou exaustão por conviver com crises, tremor e restrições funcionais. Vale comparar com a linha de base do paciente, notar se a lentificação é nova ou flutuante e observar se ela compromete atenção, elaboração e presença na sessão.

Cognição funcional: Alguns pacientes descrevem dificuldade para se concentrar, lapsos de memória recente ou sensação de raciocínio menos ágil, especialmente quando tentam retomar trabalho, estudo ou tarefas que exigem precisão. Na sessão, isso pode aparecer como perda do fio narrativo, maior necessidade de repetição ou redução da capacidade de simbolização, mas também pode refletir ansiedade, crises subclínicas, sono ruim ou sobrecarga emocional. A discriminação clínica ganha força quando se investiga o momento de início, a constância ao longo da semana e o quanto isso varia conforme contexto e demanda.

Adesão e ambivalência: Como se trata de um tratamento de uso contínuo em muitos casos, pode surgir ambivalência silenciosa: o paciente quer proteção contra crises ou tremor, mas se ressentido de depender de medicação, teme estigma ou evita tomar regularmente quando se sente bem. No consultório, isso às vezes aparece como narrativa vaga sobre horários, minimização de esquecimentos ou oscilação entre confiança e irritação com o tratamento. Também é fácil confundir piora por adesão irregular com agravamento espontâneo do quadro neurológico ou com efeitos atribuídos genericamente ao remédio.

Ansiedade antecipatória: Mesmo quando a medicação está estável, o medo de uma nova crise, de perder controle em público ou de ser visto como frágil pode organizar boa parte da vida psíquica. O terapeuta pode notar hipervigilância corporal, evitação de deslocamentos, retração social e necessidade de monitorar sinais físicos, o que por vezes parece ansiedade primária, mas pode estar ancorado em experiências reais de imprevisibilidade. Vale situar se a apreensão diminui quando o paciente se sente protegido e previsível ou se segue desproporcional ao contexto, sugerindo outros determinantes clínicos.

Identidade e funcionalidade: Em uso prolongado, o impacto mais relevante muitas vezes não é um efeito isolado, mas a forma como a condição neurológica e seu tratamento reorganizam autonomia, trabalho, direção de vida e autoimagem. Na sessão, podem aparecer vergonha, sensação de limitação, dependência maior da família ou luto pela versão anterior de si, o que pode ser lido apressadamente como depressão isolada. A observação clínica fica mais precisa quando se distingue sofrimento reativo à condição, efeitos percebidos do tratamento e mudanças reais de capacidade funcional no cotidiano.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Primidona é um anticonvulsivante usado sobretudo em epilepsia e, em alguns contextos, para tremor essencial. No consultório de terapia, tende a aparecer mais como parte do manejo de uma condição neurológica crônica do que como foco principal em si. Nas primeiras semanas e após mudanças recentes no tratamento, vale observar com mais atenção sedação, lentificação, instabilidade subjetiva e impacto funcional; ao longo dos meses, o eixo costuma ser adesão, estigma da doença, medo de crises e reorganização da rotina. O ponto central na sessão é diferenciar efeitos percebidos do tratamento, flutuações da condição de base e sobrecarga de viver sob risco de recorrência de sintomas neurológicos.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso aparece de forma mais contínua ao longo do dia ou em momentos específicos da rotina? , Essa dificuldade de atenção começou junto com alguma mudança recente no tratamento ou já vinha crescendo antes, em semanas anteriores? , Quando você esquece ou evita tomar, isso costuma acontecer por esquecimento, por incômodo com como você se sente, ou porque às vezes parece que não faz mais diferença? , O medo de ter uma crise ou piorar te acompanha mesmo em dias tranquilos, ou ele aumenta mais quando há sinais corporais, saídas de casa ou situações públicas? , Quando você se percebe mais desanimado, a sensação é de tristeza e perda de interesse, ou de estar mais travado, cansado e menos ágil para funcionar?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- lentificado ou cognitivamente mais comprometido do que sua linha de base
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar impacto funcional e temporalidade da mudança
- Quando surgem esquecimentos frequentes
- interrupções por conta própria ou adesão muito irregular
- pode valer comunicar para esclarecer se a oscilação clínica observada na terapia está sendo influenciada pelo uso inconsistente
- Quando o paciente relata piora importante de atenção
- memória ou coordenação após início recente ou mudança no tratamento
- pode valer contato com o médico para contextualizar a repercussão no cotidiano
- Quando há aumento do medo de crises
- retração funcional ou evitação marcada apesar de tratamento em curso
- pode valer alinhar com o médico para integrar leitura da condição de base e do impacto subjetivo atual

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- surgem confusão importante
- desequilíbrio acentuado
- fala muito enrolada ou rebaixamento do nível de alerta
- sobretudo se de instalação recente.: Interromper o enquadre habitual
- acionar avaliação médica no mesmo dia e rede de apoio se necessário
- Há relato de piora abrupta com suspeita de crise convulsiva recente
- quedas
- episódios de apagão ou desorientação persistente após o evento.: Priorizar segurança imediata
- orientar busca de avaliação médica urgente e acionar suporte de emergência quando o risco atual não puder ser manejado ambulatorialmente

Frase clínica

O foco clínico costuma ser menos a primidona em si e mais como sedação, adesão e medo de recorrência atravessam a vida psíquica e funcional.

042 RUFINAMIDA

Substância: Rufinamida.

Nomes Comerciais: Inovelon

Uso comum

- A rufinamida é um anticonvulsivante usado em epilepsias de difícil controle, muitas vezes em quadros crônicos e com politerapia. No consultório de terapia, ela tende a aparecer menos como foco principal e mais como parte de um tratamento complexo, em que oscilações de atenção, lentificação, fadiga ou instabilidade funcional podem se misturar ao impacto das crises, do sono fragmentado e de outras medicações. Mudanças percebidas costumam ser mais relevantes nas primeiras semanas após início ou alteração do esquema e também quando há adesão irregular. O ponto central na sessão é distinguir efeito subjetivo do tratamento, carga da doença de base e repercussão psicossocial de viver sob risco de novas crises.

O paciente pode relatar

- **"Cognição e ritmo:** Em sessão, podem surgir lentificação, dificuldade para sustentar atenção, resposta mais demorada ou sensação de estar mais travado. Isso pode acompanhar o uso da medicação, mas também pode refletir sono ruim, efeito cumulativo de politerapia, período pós- crise ou sobrecarga emocional. Vale comparar com a linha de base do paciente e observar se a oscilação é relativamente estável ao longo das semanas ou se aparece em torno de crises, noites mal dormidas ou mudanças recentes no tratamento.

Fadiga e disposição: Alguns pacientes chegam mais cansados, com menor iniciativa e redução do fôlego para elaboração, o que pode ser lido apressadamente como piora depressiva. No entanto, a fadiga também pode acompanhar o manejo da epilepsia, a recuperação após crises, a fragmentação do sono e a própria rotina de vigilância constante. A discriminação clínica ganha precisão quando o terapeuta observa se há tristeza, desesperança e autodepreciação associadas, ou se predomina um cansaço mais corporal e cognitivo.

Adesão e rotina: Em tratamentos prolongados, esquecimentos, uso irregular e pequenas rupturas na rotina podem ter impacto clínico relevante, às vezes sem que o paciente os nomeie espontaneamente. Na sessão, isso pode aparecer como relato vago de dias ruins, aumento de insegurança para sair sozinho ou medo de nova crise, sem clareza inicial sobre o que mudou. Também convém considerar que dificuldades cognitivas, dependência de cuidadores e múltiplos horários de medicação podem confundir a leitura e fazer parecer recaída emocional o que é, em parte, desorganização do tratamento.

Autonomia e identidade: Quando a epilepsia é de longa data, o sofrimento em sessão frequentemente gira em torno de restrições, supervisão familiar, vergonha, imprevisibilidade e sensação de vida interrompida. A medicação entra nesse campo menos como tema farmacológico e mais como marcador de cronicidade, dependência e diferença em relação aos pares. Mudanças de humor ou retraimento podem decorrer tanto de efeitos subjetivos do tratamento quanto do acúmulo de frustrações ligadas à condição de base, exigindo cuidado para não reduzir a experiência do paciente ao remédio."

O que observar em sessão

- **Cognição e ritmo:** Em sessão, podem surgir lentificação, dificuldade para sustentar atenção, resposta mais demorada ou sensação de estar "mais travado". Isso pode acompanhar o uso da medicação, mas também pode refletir sono ruim, efeito cumulativo de politerapia, período pós- crise ou sobrecarga emocional. Vale comparar com a linha de base do paciente e observar se a oscilação é relativamente estável ao longo das semanas ou se aparece em torno de crises, noites mal dormidas ou mudanças recentes no tratamento.

Fadiga e disposição: Alguns pacientes chegam mais cansados, com menor iniciativa e redução do fôlego para elaboração, o que pode ser lido apressadamente como piora depressiva. No entanto, a fadiga também pode acompanhar o manejo da epilepsia, a recuperação após crises, a fragmentação do sono e a própria rotina de vigilância constante. A discriminação clínica ganha precisão quando o terapeuta observa se há tristeza, desesperança e autodepreciação associadas, ou se predomina um cansaço mais corporal e cognitivo.

Adesão e rotina: Em tratamentos prolongados, esquecimentos, uso irregular e pequenas rupturas na rotina podem ter impacto clínico relevante, às vezes sem que o paciente os nomeie espontaneamente. Na sessão, isso pode aparecer como relato vago de "dias ruins", aumento de insegurança para sair sozinho ou medo de nova crise, sem clareza inicial sobre o que mudou. Também convém considerar que dificuldades cognitivas, dependência de cuidadores e múltiplos horários de medicação podem confundir a leitura e fazer parecer recaída emocional o que é, em parte, desorganização do tratamento.

Autonomia e identidade: Quando a epilepsia é de longa data, o sofrimento em sessão frequentemente gira em torno de restrições, supervisão familiar, vergonha, imprevisibilidade e sensação de vida interrompida. A medicação entra nesse campo menos como tema farmacológico e mais como marcador de cronicidade, dependência e diferença em relação aos pares. Mudanças de humor ou retraimento podem decorrer tanto de efeitos subjetivos do tratamento quanto do acúmulo de frustrações ligadas à condição de base, exigindo cuidado para não reduzir a experiência do paciente ao remédio.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A rufinamida é um anticonvulsivante usado em epilepsias de difícil controle, muitas vezes em quadros crônicos e com politerapia. No consultório de terapia, ela tende a aparecer menos como foco principal e mais como parte de um tratamento complexo, em que oscilações de atenção, lentificação, fadiga ou instabilidade funcional podem se misturar ao impacto das crises, do sono fragmentado e de outras medicações. Mudanças percebidas costumam ser mais relevantes nas primeiras semanas após início ou alteração do esquema e também quando há adesão irregular. O ponto central na sessão é distinguir efeito subjetivo do tratamento, carga da doença de base e repercussão psicossocial de viver sob risco de novas crises.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou cansado, isso fica parecido o dia inteiro ou piora em dias de sono ruim, após crises ou em períodos mais estressantes? , Nesses momentos em que você parece mais desanimado, o que predomina: tristeza e desesperança, ou mais uma sensação de corpo pesado e mente lenta? , Quando houve piora recente, aconteceu junto com alguma mudança na sua rotina de medicação, no sono ou na frequência das crises? , Essa dificuldade de atenção que você percebe é algo novo desde essa fase do tratamento ou já fazia parte do seu funcionamento entre as crises? , Quando você evita sair, estudar ou trabalhar, isso vem mais de medo de ter uma crise, de cansaço, ou de sentir que não consegue acompanhar cognitivamente?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta lentificação
- sonolência ou queda funcional novas e persistentes após mudança recente no tratamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o impacto clínico dessas alterações no conjunto do esquema terapêutico
- Quando surgem indícios de adesão irregular
- esquecimentos frequentes ou uso desorganizado em contexto de piora clínica
- pode valer comunicar o médico assistente para avaliação do risco associado à instabilidade do tratamento
- Quando o paciente ou familiares descrevem aumento de crises
- episódios de queda
- confusão recorrente ou piora importante da autonomia
- pode valer alinhar com o médico assistente para reavaliar o momento clínico
- Quando a fadiga
- a lentificação ou a dificuldade cognitiva passam a ameaçar vínculo terapêutico
- trabalho
- estudo ou autocuidado
- pode valer comunicar o médico assistente para contextualizar a perda funcional observada

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão ou entre sessões
- o paciente apresenta confusão acentuada
- rebaixamento importante do estado de alerta
- fala muito arrastada ou dificuldade incomum para se manter desperto.: Interromper o enquadre habitual e acionar avaliação médica no mesmo dia; se houver piora progressiva ou impossibilidade de manejo seguro
- recorrer à emergência e rede de apoio

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem ideias de morte ou autoagressão com aumento recente de intensidade
- planejamento ou perda de controle
- especialmente em contexto de piora global do quadro.: Fazer manejo de risco imediatamente
- acionar rede de apoio e avaliação médica no mesmo dia
- conforme a gravidade e a capacidade de proteção no momento

Frase clínica

O foco clínico é separar efeito subjetivo do tratamento, impacto das crises e carga de viver com epilepsia crônica.

043 SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAIDRATADO

Substância: Sulfato de Magnésio Heptaidratado.

Nomes Comerciais: Isofarma - Solução de Sulfato de Magnésio, Magnoston, Sulfato de Magnésio Heptahidratado

Uso comum

- Sulfato de magnésio heptaidratado é um medicamento de uso predominantemente hospitalar ou em contextos clínicos específicos, pouco frequente no consultório de psicoterapia como foco principal. Quando aparece, costuma estar ligado a intercorrências clínicas, gestação de alto risco, dor, constipação ou outras condições médicas que reorganizam a rotina do paciente. Para o terapeuta, o ponto central não é esperar um padrão psicotrópico próprio, mas acompanhar como o tratamento e a condição de base repercutem nas semanas seguintes em energia, presença na sessão, continuidade do cuidado e sensação de vulnerabilidade corporal. Mudanças abruptas no estado geral, sobretudo em período recente de internação ou atendimento de urgência, merecem leitura contextual e eventual alinhamento médico.

O paciente pode relatar

- "Carga do tratamento:** O medicamento tende a surgir no contexto de um tratamento mais amplo, muitas vezes associado a urgência clínica, internação ou acompanhamento intensivo. Na sessão, isso pode aparecer como quebra de rotina, faltas, dificuldade de manter enquadre e sensação de vida suspensa. É fácil atribuir toda mudança emocional ao remédio, quando parte importante do impacto pode vir da própria condição médica, do ambiente hospitalar ou do medo de nova intercorrência.

Vulnerabilidade corporal: Alguns pacientes chegam mais atentos ao corpo, apreensivos com sinais físicos e menos disponíveis para elaboração simbólica, especialmente após episódios agudos. O terapeuta pode notar maior concretude, redução da associação livre e foco repetido em sensações corporais ou risco de piora. Convém diferenciar se isso acompanha uma experiência médica recente e realista ou se está se ampliando para ansiedade persistente, evitação e retração da vida cotidiana.

Continuidade do cuidado: Quando o sulfato de magnésio entra na história clínica, frequentemente há múltiplos profissionais envolvidos e mudanças rápidas no plano de cuidados. Em sessão, podem aparecer informações fragmentadas, incerteza sobre o que ocorreu e oscilação entre passividade e necessidade de controle. Mais do que supor efeito direto da substância, vale observar se a dificuldade está na integração da experiência, na adesão ao seguimento clínico ou no impacto subjetivo de ter passado por um evento médico relevante."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O medicamento tende a surgir no contexto de um tratamento mais amplo, muitas vezes associado a urgência clínica, internação ou acompanhamento intensivo. Na sessão, isso pode aparecer como quebra de rotina, faltas, dificuldade de manter enquadre e sensação de vida suspensa. É fácil atribuir toda mudança emocional ao remédio, quando parte importante do impacto pode vir da própria condição médica, do ambiente hospitalar ou do medo de nova intercorrência.

Vulnerabilidade corporal: Alguns pacientes chegam mais atentos ao corpo, apreensivos com sinais físicos e menos disponíveis para elaboração simbólica, especialmente após episódios agudos. O terapeuta pode notar maior concretude, redução da associação livre e foco repetido em sensações corporais ou risco de piora. Convém diferenciar se isso acompanha uma experiência médica recente e realista ou se está se ampliando para ansiedade persistente, evitação e retração da vida cotidiana.

Continuidade do cuidado: Quando o sulfato de magnésio entra na história clínica, frequentemente há múltiplos profissionais envolvidos e mudanças rápidas no plano de cuidados. Em sessão, podem aparecer informações fragmentadas, incerteza sobre o que ocorreu e oscilação entre passividade e necessidade de controle. Mais do que supor efeito direto da substância, vale observar se a dificuldade está na integração da experiência, na adesão ao seguimento clínico ou no impacto subjetivo de ter passado por um evento médico relevante.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Sulfato de magnésio heptaidratado é um medicamento de uso predominantemente hospitalar ou em contextos clínicos específicos, pouco frequente no consultório de psicoterapia como foco principal. Quando aparece, costuma estar ligado a intercorrências clínicas, gestação de alto risco, dor, constipação ou outras condições médicas que reorganizam a rotina do paciente. Para o terapeuta, o ponto central não é esperar um padrão psicotrópico próprio, mas acompanhar como o tratamento e a condição de base repercutem nas semanas seguintes em energia, presença na sessão, continuidade do cuidado e sensação de vulnerabilidade corporal. Mudanças abruptas no estado geral, sobretudo em período recente de internação ou atendimento de urgência, merecem leitura contextual e eventual alinhamento médico.

Perguntas úteis

- "O que mudou mais desde esse atendimento: seu corpo, seu humor ou a forma como você passou a se sentir em relação à sua saúde? , Quando você se percebe mais apreensivo, isso vem junto de algum sintoma físico concreto ou aparece mesmo quando o corpo está estável? , Essa dificuldade de estar presente aqui começou depois do tratamento em si ou já vinha se formando antes, com a situação que levou ao atendimento? , Desde esse episódio, você sente que está evitando retomar atividades por limitação física, por medo de passar mal de novo, ou pelos dois motivos?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega à sessão confuso sobre o que ocorreu em atendimento recente
- com informações muito fragmentadas e piora do estado geral
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o momento clínico atual
- Quando há faltas repetidas
- interrupção do acompanhamento ou dificuldade importante de continuidade por intercorrências médicas em curso
- pode valer contato com o médico para compreender a estabilidade do tratamento
- Quando o paciente descreve piora física relevante após uso recente ou após alta
- especialmente se isso repercute claramente no funcionamento e na capacidade de comparecer às sessões
- pode valer alinhamento médico para atualização do quadro

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente parece confuso
- muito sonolento
- desorganizado ou com rebaixamento importante do estado de alerta em comparação ao seu padrão habitual.: Interromper o trabalho interpretativo
- avaliar segurança imediata e acionar atendimento médico no mesmo dia
- com rede de apoio e emergência se necessário
- Surge falta de ar
- fraqueza intensa
- piora súbita do estado geral ou incapacidade de se manter responsivo durante a sessão.: Tratar como intercorrência clínica aguda e acionar suporte médico imediato ou serviço de emergência

Frase clínica

O foco clínico costuma estar menos no fármaco e mais no impacto subjetivo de uma condição médica aguda ou de um tratamento intensivo.

044 TOPIRAMATO

Substância: Topiramato.

Nomes Comerciais: Égide, Amato, Topiramato, Toduze, Têmpora, Vidmax, Topamax, Arasid

Uso comum

- Topiramato é um anticonvulsivante que também pode aparecer em pacientes acompanhados por enxaqueca, compulsão alimentar, controle de peso ou uso psiquiátrico adjuvante. No consultório, costuma chamar atenção menos por mudança afetiva direta e mais por lentificação cognitiva, dificuldade de encontrar palavras, oscilação de energia, redução do apetite e adesão irregular por incômodo subjetivo. Esses efeitos podem surgir já nas primeiras semanas e, quando aparecem, às vezes são confundidos com piora depressiva, desatenção basal ou sobrecarga. Ao longo de 4 a 8 semanas, vale observar se o paciente descreve adaptação, manutenção do prejuízo funcional ou abandono silencioso.

O paciente pode relatar

- **"Cognição e linguagem:** Alguns pacientes passam a chegar à sessão mais lentos para organizar ideias, com pausas incomuns, dificuldade para recuperar palavras ou sensação de “cabeça travada”. Isso pode ser lido apressadamente como retraimento depressivo, desatenção crônica ou efeito de privação de sono, sobretudo quando o quadro de base já inclui queixa cognitiva. O ponto útil é comparar com a linha de base: se a fluência, a velocidade associativa e a capacidade de sustentar elaboração mudaram depois do início do medicamento, vale registrar o padrão e o impacto funcional fora da sessão.

Apetite e peso: Pode surgir redução do apetite, menor interesse por comida ou emagrecimento percebido como alívio, estranheza ou ambivalência, dependendo da história corporal do paciente. Em terapia, isso às vezes se mistura com melhora de compulsão alimentar, maior autocontrole, estresse agudo ou reativação de conflitos ligados a imagem corporal. A discriminação clínica passa por observar se houve mudança espontânea e consistente no impulso de comer, se o paciente está evitando refeições por falta de fome ou por intenção deliberada, e se isso alterou humor, energia e rotina.

Energia e lentificação: O paciente pode descrever cansaço, sensação de estar mais “devagar” ou menor prontidão mental, o que na sessão aparece como menor iniciativa associativa e resposta mais demorada. Esse quadro pode se confundir com piora depressiva, exaustão por dor crônica, sobrecarga de trabalho ou efeito combinado de outras medicações sedativas. Vale notar se a redução de energia vem acompanhada de humor mais deprimido e desesperança, ou se predomina uma lentificação sem o mesmo conteúdo afetivo, especialmente quando a mudança temporal coincide com o início do uso.

Humor e irritabilidade: Embora não seja o traço mais típico, alguns pacientes referem irritabilidade, oscilação de tolerância ou sensação de estranhamento subjetivo que interfere no vínculo e na vida doméstica. Na sessão, isso pode parecer aumento de reatividade, impaciência com o próprio raciocínio ou menor disponibilidade para elaboração. Como dor, frustração com efeitos corporais, privação de sono e conflitos atuais também modulam humor, ajuda explorar se a irritabilidade surgiu junto de outras mudanças cognitivas ou físicas e se representa continuação do padrão prévio ou algo novo.

Adesão silenciosa: Topiramato pode ser abandonado sem anúncio quando o paciente sente que está “funcionando pior”, comendo menos do que gostaria ou ficando desconfortável com o próprio rendimento. Em psicoterapia, isso aparece como narrativa vaga de melhora e piora, inconsistência entre semanas ou dificuldade de ligar mudanças subjetivas ao uso regular. Quando a cronologia fica confusa, convém perguntar de modo direto sobre continuidade, esquecimentos e interrupções por conta própria, porque adesão irregular pode imitar tanto ineficácia quanto instabilidade do quadro."

O que observar em sessão

- **Cognição e linguagem:** Alguns pacientes passam a chegar à sessão mais lentos para organizar ideias, com pausas incomuns, dificuldade para recuperar palavras ou sensação de “cabeça travada”. Isso pode ser lido apressadamente como retraimento depressivo, desatenção crônica ou efeito de privação de sono, sobretudo quando o quadro de base já inclui queixa cognitiva. O ponto útil é comparar com a linha de base: se a fluência, a velocidade associativa e a capacidade de sustentar elaboração mudaram depois do início do medicamento, vale registrar o padrão e o impacto funcional fora da sessão.

Apetite e peso: Pode surgir redução do apetite, menor interesse por comida ou emagrecimento percebido como alívio, estranheza ou ambivalência, dependendo da história corporal do paciente. Em terapia, isso às vezes se mistura com melhora de compulsão alimentar, maior autocontrole, estresse agudo ou reativação de conflitos ligados a imagem corporal. A discriminação clínica passa por observar se houve mudança espontânea e consistente no impulso de comer, se o paciente está evitando refeições por falta de fome ou por intenção deliberada, e se isso alterou humor, energia e rotina.

Energia e lentificação: O paciente pode descrever cansaço, sensação de estar mais “devagar” ou menor prontidão mental, o que na sessão aparece como menor iniciativa associativa e resposta mais demorada. Esse quadro pode se confundir com piora depressiva, exaustão por dor crônica, sobrecarga de trabalho ou efeito combinado de outras medicações sedativas. Vale notar se a redução de energia vem acompanhada de humor mais deprimido e desesperança, ou se predomina uma lentificação sem o mesmo conteúdo afetivo, especialmente quando a mudança temporal coincide com o início do uso.

Humor e irritabilidade: Embora não seja o traço mais típico, alguns pacientes referem irritabilidade, oscilação de tolerância ou sensação de estranhamento subjetivo que interfere no vínculo e na vida doméstica. Na sessão, isso pode parecer aumento de reatividade, impaciência com o próprio raciocínio ou menor disponibilidade para elaboração. Como dor, frustração com efeitos corporais, privação de sono e conflitos atuais também modulam humor, ajuda explorar se a irritabilidade surgiu junto de outras mudanças cognitivas ou físicas e se representa continuação do padrão prévio ou algo novo.

Adesão silenciosa: Topiramato pode ser abandonado sem anúncio quando o paciente sente que está “funcionando pior”, comendo menos do que gostaria ou ficando desconfortável com o próprio rendimento. Em psicoterapia, isso aparece como narrativa vaga de melhora e piora, inconsistência entre semanas ou dificuldade de ligar mudanças subjetivas ao uso regular. Quando a cronologia fica confusa, convém perguntar de modo direto sobre continuidade, esquecimentos e interrupções por conta própria, porque adesão irregular pode imitar tanto ineficácia quanto instabilidade do quadro.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Topiramato é um anticonvulsivante que também pode aparecer em pacientes acompanhados por enxaqueca, compulsão alimentar, controle de peso ou uso psiquiátrico adjuvante. No consultório, costuma chamar atenção menos por mudança afetiva direta e mais por lentificação cognitiva, dificuldade de encontrar palavras, oscilação de energia, redução do apetite e adesão irregular por incômodo subjetivo. Esses efeitos podem surgir já nas primeiras semanas e, quando aparecem, às vezes são confundidos com piora depressiva, desatenção basal ou sobrecarga. Ao longo de 4 a 8 semanas, vale observar se o paciente descreve adaptação, manutenção do prejuízo funcional ou abandono silencioso.

Perguntas úteis

- "Quando você sente a cabeça mais lenta, isso vem junto de tristeza e desesperança ou é mais uma dificuldade de pensar e achar palavras, mesmo sem piora clara do humor? , Essa mudança no apetite parece falta de fome espontânea, mudança na compulsão ou uma tentativa sua de comer menos por objetivo de peso? , Nos dias em que você se percebe mais devagar, isso acontece desde o começo do dia ou aparece em momentos específicos, como após noites ruins, crises de dor ou uso irregular da medicação? , A irritabilidade que apareceu recentemente se parece com o seu padrão habitual sob estresse ou veio acompanhada de outras mudanças, como lentidão mental, menos apetite ou sensação corporal diferente? , Houve dias em que você pulou, esqueceu ou interrompeu o remédio por conta do que estava sentindo, e o que mudou nesses dias em comparação com os outros?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar prejuízo cognitivo persistente que interfere em trabalho
- estudo ou manejo da rotina
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a intensidade e a cronologia dessa mudança
- Quando há redução importante do apetite ou perda de peso percebida como difícil de sustentar
- pode valer comunicar o médico para avaliação do impacto funcional e da continuidade do tratamento
- Quando a adesão fica irregular por incômodo com lentificação
- linguagem ou alimentação
- pode valer contato com o médico porque o quadro subjetivo pode ser lido de forma equivocada se a cronologia não estiver clara
- Quando surgem irritabilidade ou reatividade novas junto de outras mudanças após o início do uso
- pode valer alinhar com o médico para diferenciar efeito do tratamento
- evolução do quadro de base e fatores contextuais
- Quando
- após 4 a 8 semanas

Amarelo: alinhar em breve

- o paciente segue sem perceber benefício e a sessão fica dominada por efeitos que comprometem funcionamento
- pode valer comunicar o médico assistente para atualização do quadro clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente aparece marcadamente confuso
- desorientado
- muito sonolento ou com fala tão prejudicada que não consegue sustentar contato clínico habitual.: Interromper o manejo usual
- avaliar segurança imediata e acionar no mesmo dia o médico assistente
- rede de apoio ou serviço de urgência conforme gravidade
- Surge ideação suicida nova ou claramente intensificada
- sobretudo quando acompanhada de piora abrupta do humor
- agitação ou sensação de estranhamento importante após início recente do uso.: Fazer avaliação de risco
- acionar suporte imediato e contatar no mesmo dia o médico assistente; recorrer à emergência se houver risco iminente

Frase clínica

O foco clínico costuma estar menos no humor e mais em quando a sessão começa a mostrar lentificação cognitiva, linguagem travada, apetite reduzido e adesão silenciosa.

045 VALPROATO DE SÓDIO

Substância: Valproato de Sódio.

Nomes Comerciais: Valproato de Sódio, Torval Cr, Depakene, Epilenil, Ácido Valpróico, Valproato de Sódio, Lavie

Uso comum

- Valproato de sódio é um anticonvulsivante que também aparece com frequência no tratamento de transtorno bipolar e, em alguns casos, como adjuvante em quadros de irritabilidade ou impulsividade. No consultório, costuma entrar menos pelo “efeito antidepressivo” e mais pela modulação de oscilação de humor, impulsividade e reatividade. Quando está sendo iniciado ou retomado, as primeiras 1 a 3 semanas costumam concentrar mudanças de tolerabilidade percebidas na sessão; ao longo de 2 a 6 semanas, vale observar se há redução de aceleração, explosividade ou instabilidade. O ponto central é diferenciar estabilização clínica de lentificação excessiva, sedação, embotamento ou adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento: fala menos ágil, maior sonolência, dificuldade de sustentar atenção ou sensação de "corpo pesado". Isso pode ser lido apressadamente como melhora da agitação, quando às vezes se aproxima mais de sedação ou lentificação subjetivamente incômoda. Também convém separar esse padrão de privação de sono, uso concomitante de outras medicações sedativas, consumo de álcool ou piora depressiva com queda de energia.

Humor e reatividade: Quando o valproato está sendo usado em quadros bipolares ou de desregulação afetiva, pode haver redução de explosividade, menor escalada de conflitos e mais intervalo entre impulso e ação. Na sessão, isso pode aparecer como maior continência afetiva, menos urgência e menor pressão relacional, mas sem necessariamente significar elaboração mais profunda. Vale distinguir estabilização de um achatamento novo, e também de uma fase do contexto de vida momentaneamente menos estressante ou de adesão irregular que produz dias muito diferentes entre si.

Cognição e clareza: Alguns pacientes descrevem pensamento mais "pesado", dificuldade para encontrar palavras, menor velocidade mental ou sensação de estar menos afiado. O terapeuta pode notar respostas mais demoradas, menor espontaneidade associativa e necessidade de repetir perguntas, o que pode confundir a leitura de resistência, desinvestimento ou retraimento depressivo. A discriminação clínica depende de comparar com a linha de base, com o horário da sessão e com a presença de outras substâncias ou noites mal dormidas.

Apetite e corpo: Mudanças de apetite, sensação de inchaço ou ganho de peso podem entrar na sessão não só como dado físico, mas como tema de autoestima, sexualidade, vergonha e adesão silenciosa. Às vezes o paciente não nomeia incômodo com a medicação, mas passa a evitar espelho, contato íntimo ou situações sociais, e isso pode ser confundido com piora depressiva primária. Quando essas mudanças aparecem cedo e com impacto subjetivo importante, vale observar se estão alterando rotina, imagem corporal e disposição para manter o tratamento.

Adesão e continuidade: O uso irregular pode produzir um padrão clínico enganoso: dias de maior lentificação alternados com retorno de irritabilidade, impulsividade ou instabilidade, sem que o paciente inicialmente associe isso ao modo como está tomando a medicação. Na terapia, isso costuma surgir como narrativa de oscilação aparentemente "sem motivo" ou como ambivalência pouco explicitada em relação ao tratamento. Mais do que perguntar se toma "certo", ajuda mapear esquecimentos, interrupções por conta própria e abandono silencioso motivado por efeitos percebidos no corpo ou no funcionamento.

Sinais físicos relevantes: Embora o foco da sessão não seja exame físico, alguns sinais corporais têm valor clínico quando aparecem junto de mal-estar importante: tremor novo, náusea persistente, vômitos, desequilíbrio, fala arrastada ou sonolência fora do padrão. Isoladamente, podem ter múltiplas explicações; em conjunto, sobretudo se surgem de forma mais abrupta, pedem cautela para não serem atribuídos apenas à ansiedade ou ao cansaço. O terapeuta não precisa interpretar o mecanismo, mas pode registrar a combinação de sinais, o momento de início e o impacto funcional."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento: fala menos ágil, maior sonolência, dificuldade de sustentar atenção ou sensação de “corpo pesado”. Isso pode ser lido apressadamente como melhora da agitação, quando às vezes se aproxima mais de sedação ou lentificação subjetivamente incômoda. Também convém separar esse padrão de privação de sono, uso concomitante de outras medicações sedativas, consumo de álcool ou piora depressiva com queda de energia.

Humor e reatividade: Quando o valproato está sendo usado em quadros bipolares ou de desregulação afetiva, pode haver redução de explosividade, menor escalada de conflitos e mais intervalo entre impulso e ação. Na sessão, isso pode aparecer como maior continência afetiva, menos urgência e menor pressão relacional, mas sem necessariamente significar elaboração mais profunda. Vale distinguir estabilização de um achatamento novo, e também de uma fase do contexto de vida momentaneamente menos estressante ou de adesão irregular que produz dias muito diferentes entre si.

Cognição e clareza: Alguns pacientes descrevem pensamento mais “pesado”, dificuldade para encontrar palavras, menor velocidade mental ou sensação de estar menos afiado. O terapeuta pode notar respostas mais demoradas, menor espontaneidade associativa e necessidade de repetir perguntas, o que pode confundir a leitura de resistência, desinvestimento ou retraimento depressivo. A discriminação clínica depende de comparar com a linha de base, com o horário da sessão e com a presença de outras substâncias ou noites mal dormidas.

Apetite e corpo: Mudanças de apetite, sensação de inchaço ou ganho de peso podem entrar na sessão não só como dado físico, mas como tema de autoestima, sexualidade, vergonha e adesão silenciosa. Às vezes o paciente não nomeia incômodo com a medicação, mas passa a evitar espelho, contato íntimo ou situações sociais, e isso pode ser confundido com piora depressiva primária. Quando essas mudanças aparecem cedo e com impacto subjetivo importante, vale observar se estão alterando rotina, imagem corporal e disposição para manter o tratamento.

Adesão e continuidade: O uso irregular pode produzir um padrão clínico enganoso: dias de maior lentificação alternados com retorno de irritabilidade, impulsividade ou instabilidade, sem que o paciente inicialmente associe isso ao modo como está tomando a medicação. Na terapia, isso costuma surgir como narrativa de oscilação aparentemente “sem motivo” ou como ambivalência pouco explicitada em relação ao tratamento. Mais do que perguntar se toma “certo”, ajuda mapear esquecimentos, interrupções por conta própria e abandono silencioso motivado por efeitos percebidos no corpo ou no funcionamento.

Sinais físicos relevantes: Embora o foco da sessão não seja exame físico, alguns sinais corporais têm valor clínico quando aparecem junto de mal-estar importante: tremor novo, náusea persistente, vômitos, desequilíbrio, fala arrastada ou sonolência fora do padrão. Isoladamente, podem ter múltiplas explicações; em conjunto, sobretudo se surgem de forma mais abrupta, pedem cautela para não serem atribuídos apenas à ansiedade ou ao cansaço. O terapeuta não precisa interpretar o mecanismo, mas pode registrar a combinação de sinais, o momento de início e o impacto funcional.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Valproato de sódio é um anticonvulsivante que também aparece com frequência no tratamento de transtorno bipolar e, em alguns casos, como adjuvante em quadros de irritabilidade ou impulsividade. No consultório, costuma entrar menos pelo “efeito antidepressivo” e mais pela modulação de oscilação de humor, impulsividade e reatividade. Quando está sendo iniciado ou retomado, as primeiras 1 a 3 semanas costumam concentrar mudanças de tolerabilidade percebidas na sessão; ao longo de 2 a 6 semanas, vale observar se há redução de aceleração, explosividade ou instabilidade. O ponto central é diferenciar estabilização clínica de lentificação excessiva, sedação, embotamento ou adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso vem como um acalmar que ajuda ou como um apagamento que atrapalha pensar, trabalhar ou se envolver aqui na sessão? , Essa redução da intensidade emocional parece vir junto de mais capacidade de escolher como agir, ou de uma sensação de estar meio desligado do que sente? , Nos dias em que você fica mais irritado ou acelerado, isso acontece de modo contínuo ao longo da semana ou alterna com dias em que você tomou, esqueceu ou evitou a medicação? , Essa dificuldade de concentração se parece com tristeza e desânimo, ou com uma sensação mais corporal de cabeça pesada e pensamento mais lento? , As mudanças no corpo ou no peso mexeram mais com sua autoestima e desejo de se aproximar das pessoas, ou você percebe isso como algo secundário diante do restante do quadro? , Quando sua energia sobe, isso vem com menos necessidade de dormir, mais impulsos e sensação de estar “rápido demais”, ou é só um dia melhor dentro do seu ritmo habitual?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- lentificado ou cognitivamente mais opaco do que sua linha de base
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar estabilização de tolerabilidade ruim com impacto funcional
- Quando surgem tremor novo
- vômitos
- desequilíbrio
- fala arrastada ou sonolência importante em combinação
- pode valer contato com o médico assistente para checar segurança clínica
- Quando há ganho de peso
- inchaço percebido ou mudanças corporais que começam a comprometer autoestima
- sexualidade ou adesão silenciosa
- pode ser útil comunicar o psiquiatra pelo risco de abandono não dito
- Quando o paciente descreve esquecimentos frequentes

Amarelo: alinhar em breve

- interrupções por conta própria ou uso muito irregular acompanhado de oscilação de humor e impulsividade
- pode valer alinhar com o médico para contextualizar a leitura do quadro
- Quando
 - após algumas semanas
 - não se observa redução de instabilidade
 - explosividade ou aceleração que motivaram o uso
- pode ser pertinente comunicar o psiquiatra para revisão da evolução clínica
- Quando aparece aumento de energia com menos sono
 - impulsividade
 - grandiosidade ou expansão incomum do humor
- pode valer contato com o médico para discutir possível mudança de estado de humor

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- aparecem juntos mal-estar importante
- vômitos
- tremor acentuado
- desequilíbrio
- fala arrastada ou sonolência intensa fora do padrão.: Acionar avaliação médica no mesmo dia; se houver rebaixamento importante do estado geral
- considerar rede de apoio e emergência
- Surge aceleração marcante com pouca necessidade de dormir
- impulsividade
- expansividade incomum ou sensação de estar “rápido demais” em relação ao habitual.: Tratar como mudança aguda relevante do estado mental
- contatar o psiquiatra hoje e avaliar necessidade de apoio adicional
- Aparece ideação suicida com aumento de impulso
- desesperança intensa ou perda de controle
- especialmente em contexto de oscilação rápida do humor.: Fazer manejo de risco imediatamente
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- com emergência quando necessário

Frase clínica

O foco é distinguir estabilização do humor de lentificação excessiva, embotamento e uso irregular que embaralha a leitura da sessão.

046 CARBIDOPA (PORT. 344/98 LISTA C 1); ENTACAPONA; LEVODOPA

Substância: Carbidopa (Port. 344/98 Lista C 1); Entacapona; Levodopa.
Nomes Comerciais: Stalevo

Uso comum

- Combinação usada na doença de Parkinson para reduzir rigidez, lentidão e flutuações motoras ao longo do dia. No consultório, o ponto central costuma ser a oscilação entre períodos em que o paciente está mais solto e disponível e outros em que fica mais travado, fatigado ou mentalmente mais lento, às vezes em relação previsível com os horários de uso. Quando o esquema está em ajuste ou a doença está mais instável, essas variações podem ficar mais nítidas ao longo de dias e semanas. Para o terapeuta, vale acompanhar como essas mudanças interferem na fala, no acesso afetivo, na autonomia, no humor e na continuidade do trabalho terapêutico, sem atribuir automaticamente tudo ao medicamento.

O paciente pode relatar

- **"Oscilação ao longo do dia:** Alguns pacientes chegam à sessão descrevendo janelas em que o corpo responde melhor e outras em que voltam a ficar mais lentos, rígidos ou dependentes para tarefas simples. Na sessão, isso pode aparecer como variação de fluência verbal, tempo de resposta, expressividade facial e facilidade para entrar em contato com o próprio material psíquico. O que confunde a leitura é que frustração, ansiedade antecipatória, privação de sono e progressão do quadro neurológico também podem produzir aparente piora, sem que se trate apenas de efeito do medicamento.

Movimentos involuntários: Em parte dos pacientes, podem surgir movimentos excessivos, contorções, inquietação motora ou dificuldade de permanecer confortável na cadeira, sobretudo em momentos em que o paciente se sente fisicamente mais "solto". Na sessão, isso pode ser confundido com ansiedade, agitação emocional ou estilo corporal habitual, especialmente se o conteúdo verbal não acompanha o grau de movimentação observado. Vale discriminar se os movimentos aparecem em certos horários, se são percebidos como involuntários e se atrapalham concentração, vergonha social ou permanência em atividades.

Humor e reatividade: Melhora motora pode vir acompanhada de alívio, retomada de iniciativa e maior investimento na vida, mas também pode coexistir com irritabilidade, labilidade emocional ou desânimo quando o funcionamento corporal oscila muito. O terapeuta pode observar mudanças no tom afetivo entre sessões, maior sensibilidade a perdas de autonomia e reações intensas a pequenas frustrações. Essas apresentações podem se misturar ao impacto subjetivo de uma doença crônica progressiva, a eventos de vida e a expectativas frustradas de recuperação mais ampla.

Cognição e ritmo mental: Alguns pacientes parecem mais lentos para organizar pensamento, sustentar atenção ou acompanhar encadeamentos mais longos, enquanto outros relatam momentos de maior clareza quando o corpo está melhor. Na sessão, isso pode aparecer como latência aumentada, dificuldade para recuperar palavras, perda do fio da narrativa ou oscilação importante entre encontros. Pode confundir porque depressão, apatia, fadiga, dor, sono ruim e o próprio curso da doença também afetam cognição e velocidade de processamento.

Sono e experiências perceptivas: Sonolência diurna, cochilos involuntários, sonhos vívidos e, em alguns casos, experiências perceptivas incomuns podem entrar no relato, às vezes com preservação parcial da crítica. O terapeuta pode notar queda abrupta de vigilância, dificuldade de manter presença na sessão ou hesitação em contar algo por medo de parecer "confuso". Nem toda alteração perceptiva indica desorganização ampla: isolamento, luto, infecção, outras medicações e piora cognitiva também podem participar do quadro e merecem ser considerados.

Autonomia e identidade: Como o tratamento costuma modular a capacidade de se mover e agir, pequenas mudanças corporais podem ter grande impacto na autoestima, na sensação de dignidade e na disposição para sair de casa, trabalhar ou manter vínculos. Na sessão, isso aparece no modo como o paciente narra dependência, vergonha, evitamento social ou alívio por conseguir retomar partes da rotina. O risco clínico é reduzir tudo a "adaptação à doença" e perder de vista que oscilações do tratamento, adesão irregular e constrangimentos concretos do cotidiano podem estar reorganizando a experiência subjetiva."

O que observar em sessão

- **Oscilação ao longo do dia:** Alguns pacientes chegam à sessão descrevendo janelas em que o corpo responde melhor e outras em que voltam a ficar mais lentos, rígidos ou dependentes para tarefas simples. Na sessão, isso pode aparecer como variação de fluência verbal, tempo de resposta, expressividade facial e facilidade para entrar em contato com o próprio material psíquico. O que confunde a leitura é que frustração, ansiedade antecipatória, privação de sono e progressão do quadro neurológico também podem produzir aparente piora, sem que se trate apenas de efeito do medicamento.

Movimentos involuntários: Em parte dos pacientes, podem surgir movimentos excessivos, contorções, inquietação motora ou dificuldade de permanecer confortável na cadeira, sobretudo em momentos em que o paciente se sente fisicamente mais “solto”. Na sessão, isso pode ser confundido com ansiedade, agitação emocional ou estilo corporal habitual, especialmente se o conteúdo verbal não acompanha o grau de movimentação observado. Vale discriminar se os movimentos aparecem em certos horários, se são percebidos como involuntários e se atrapalham concentração, vergonha social ou permanência em atividades.

Humor e reatividade: Melhora motora pode vir acompanhada de alívio, retomada de iniciativa e maior investimento na vida, mas também pode coexistir com irritabilidade, labilidade emocional ou desânimo quando o funcionamento corporal oscila muito. O terapeuta pode observar mudanças no tom afetivo entre sessões, maior sensibilidade a perdas de autonomia e reações intensas a pequenas frustrações. Essas apresentações podem se misturar ao impacto subjetivo de uma doença crônica progressiva, a eventos de vida e a expectativas frustradas de recuperação mais ampla.

Cognição e ritmo mental: Alguns pacientes parecem mais lentos para organizar pensamento, sustentar atenção ou acompanhar encadeamentos mais longos, enquanto outros relatam momentos de maior clareza quando o corpo está melhor. Na sessão, isso pode aparecer como latência aumentada, dificuldade para recuperar palavras, perda do fio da narrativa ou oscilação importante entre encontros. Pode confundir porque depressão, apatia, fadiga, dor, sono ruim e o próprio curso da doença também afetam cognição e velocidade de processamento.

Sono e experiências perceptivas: Sonolência diurna, cochilos involuntários, sonhos vívidos e, em alguns casos, experiências perceptivas incomuns podem entrar no relato, às vezes com preservação parcial da crítica. O terapeuta pode notar queda abrupta de vigilância, dificuldade de manter presença na sessão ou hesitação em contar algo por medo de parecer “confuso”. Nem toda alteração perceptiva indica desorganização ampla: isolamento, luto, infecção, outras medicações e piora cognitiva também podem participar do quadro e merecem ser considerados.

Autonomia e identidade: Como o tratamento costuma modular a capacidade de se mover e agir, pequenas mudanças corporais podem ter grande impacto na autoestima, na sensação de dignidade e na disposição para sair de casa, trabalhar ou manter vínculos. Na sessão, isso aparece no modo como o paciente narra dependência, vergonha, evitamento social ou alívio por conseguir retomar partes da rotina. O risco clínico é reduzir tudo a “adaptação à doença” e perder de vista que oscilações do tratamento, adesão irregular e constrangimentos concretos do cotidiano podem estar reorganizando a experiência subjetiva.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Combinação usada na doença de Parkinson para reduzir rigidez, lentidão e flutuações motoras ao longo do dia. No consultório, o ponto central costuma ser a oscilação entre períodos em que o paciente está mais solto e disponível e outros em que fica mais travado, fatigado ou mentalmente mais lento, às vezes em relação previsível com os horários de uso. Quando o esquema está em ajuste ou a doença está mais instável, essas variações podem ficar mais nítidas ao longo de dias e semanas. Para o terapeuta, vale acompanhar como essas mudanças interferem na fala, no acesso afetivo, na autonomia, no humor e na continuidade do trabalho terapêutico, sem atribuir automaticamente tudo ao medicamento.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente pior entre um período e outro, isso costuma vir primeiro como mudança no corpo, no humor ou nos dois ao mesmo tempo? , Esses movimentos ou essa inquietação que aparecem em alguns momentos parecem com ansiedade sua de costume ou parecem acontecer no corpo mesmo quando você não está particularmente ansioso? , Nos dias em que você fica mais lento ou sonolento, isso se parece mais com tristeza e falta de vontade ou com dificuldade de o corpo e a atenção acompanharem? , Quando você percebe imagens, sons ou presenças incomuns, isso acontece em momentos de muito sono, à noite, ou também quando você está bem desperto? , Você nota se há horários do dia em que falar, pensar ou se mover fica claramente mais fácil ou mais difícil do que em outros? , Quando você evita sair ou encontrar pessoas, isso vem mais do receio de travar ou se mover mal, da vergonha dos movimentos involuntários, ou de desânimo mais geral?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve oscilação muito marcada entre períodos de bom e mau funcionamento ao longo do dia
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a intensidade das flutuações e o impacto funcional
- Quando movimentos involuntários passam a constranger
- dificultar permanência na sessão ou reduzir adesão a atividades
- pode valer comunicar ao médico para registro da mudança clínica
- Quando surgem sonolência importante
- cochilos involuntários ou queda de vigilância em atividades do cotidiano
- pode valer contato com o médico pela repercussão em segurança e funcionalidade
- Quando aparecem experiências perceptivas incomuns
- sobretudo se novas ou em ampliação
- pode valer alinhar com o médico para diferenciar fenômenos transitórios de mudança clínica mais relevante
- Quando o paciente passa a faltar
- desorganiza horários ou relata uso irregular em meio a piora subjetiva

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicar ao médico porque a leitura do quadro fica mais difícil e o risco de abandono silencioso aumenta

Vermelho: tratar como urgência

- Surge confusão acentuada
- desorientação
- fala muito desconexa ou rebaixamento importante do nível de consciência durante a sessão.: Interromper o trabalho habitual
- acionar familiar ou rede de apoio e buscar avaliação médica no mesmo dia
- recorrendo à emergência se necessário
- Experiências perceptivas passam a vir com perda de crítica
- medo intenso
- comportamento desorganizado ou risco de agir em resposta ao que percebe.: Acionar o médico assistente no mesmo dia e mobilizar rede de apoio e emergência conforme o grau de risco

Frase clínica

O foco clínico é acompanhar flutuações entre corpo, cognição e humor sem confundir oscilação motora com mudança psíquica primária.

047 CARBIDOPA (PORT. 344/98 LISTA C 1);LEVODOPA

Substância: Carbidopa (Port. 344/98 Lista C 1);Levodopa.

Nomes Comerciais: Parkidopa, Carbidol

Uso comum

- Associação usada sobretudo na doença de Parkinson e em alguns quadros parkinsonianos, geralmente em tratamento contínuo e de longa duração. No consultório de terapia, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como as oscilações motoras e não motoras ao longo do dia atravessam humor, autonomia, ritmo da sessão e senso de identidade. Mudanças podem aparecer após início ou ajustes recentes, mas também ao longo de meses e anos de tratamento, com variação entre períodos de maior fluidez e momentos de travamento, lentificação ou cansaço. Vale acompanhar a relação temporal entre funcionamento, horário das tomadas, sono, frustração e adesão.

O paciente pode relatar

- **"Oscilação no dia:** Alguns pacientes chegam descrevendo janelas em que se sentem mais soltos, presentes e funcionais, alternadas com períodos de travamento, lentificação, rigidez ou maior dependência. Na sessão, isso pode aparecer como variação marcante de expressividade, velocidade de fala, iniciativa e tolerância à frustração entre encontros ou dentro do mesmo dia. Essas mudanças podem ser confundidas com instabilidade emocional primária, desânimo depressivo ou reação a eventos de vida, quando às vezes acompanham mais de perto o ritmo corporal e a regularidade do uso.

Humor e reatividade: Frustração, irritabilidade, desânimo e sensação de perda de si podem ganhar relevo à medida que a doença interfere na autonomia e na previsibilidade do cotidiano. Em alguns casos, o paciente parece mais reativo emocionalmente quando o corpo falha; em outros, a apatia se impõe e pode lembrar piora depressiva. Convém diferenciar o que acompanha limitações funcionais progressivas, o que surge em torno de oscilações do tratamento e o que se relaciona a lutos, aposentadoria, isolamento ou mudanças familiares.

Cognição e ritmo: Lentificação do pensamento, dificuldade para iniciar respostas, flutuação atencional e maior esforço para organizar a narrativa podem aparecer na sessão. Isso pode ser lido apressadamente como resistência, desinteresse ou retraimento afetivo, quando às vezes reflete o custo cognitivo e motor do momento. Também é útil considerar sono ruim, dor, outras medicações sedativas e progressão do quadro neurológico antes de atribuir a mudança a um único fator.

Sono e sonhos: O sono pode ficar fragmentado, com sonolência diurna, cochilos involuntários ou relatos de sonhos vívidos, o que repercute diretamente na disponibilidade psíquica para elaborar em sessão. O terapeuta pode notar oscilação entre torpor e maior alerta, além de lapsos de atenção que lembram desmotivação. Como esse campo também sofre impacto de ansiedade, depressão, rotina doméstica e comorbidades clínicas, vale mapear padrão, horário e contexto em vez de concluir por uma causa única.

Autonomia e identidade: À medida que o tratamento se torna parte central da rotina, o paciente pode oscilar entre gratidão por manter funcionalidade e ressentimento por depender de horários, ajuda de terceiros e adaptações. Na sessão, isso costuma tocar autoestima, vergonha, sexualidade, imagem corporal e medo de se tornar um peso. Parte do sofrimento vem da condição de base e de suas perdas cumulativas, não apenas do tratamento, e essa distinção ajuda a sustentar elaboração sem reduzir tudo ao medicamento."

O que observar em sessão

- **Oscilação no dia:** Alguns pacientes chegam descrevendo janelas em que se sentem mais soltos, presentes e funcionais, alternadas com períodos de travamento, lentificação, rigidez ou maior dependência. Na sessão, isso pode aparecer como variação marcante de expressividade, velocidade de fala, iniciativa e tolerância à frustração entre encontros ou dentro do mesmo dia. Essas mudanças podem ser confundidas com instabilidade emocional primária, desânimo depressivo ou reação a eventos de vida, quando às vezes acompanham mais de perto o ritmo corporal e a regularidade do uso.

Humor e reatividade: Frustração, irritabilidade, desânimo e sensação de perda de si podem ganhar relevo à medida que a doença interfere na autonomia e na previsibilidade do cotidiano. Em alguns casos, o paciente parece mais reativo emocionalmente quando o corpo falha; em outros, a apatia se impõe e pode lembrar piora depressiva. Convém diferenciar o que acompanha limitações funcionais progressivas, o que surge em torno de oscilações do tratamento e o que se relaciona a lutos, aposentadoria, isolamento ou mudanças familiares.

Cognição e ritmo: Lentificação do pensamento, dificuldade para iniciar respostas, flutuação atencional e maior esforço para organizar a narrativa podem aparecer na sessão. Isso pode ser lido apressadamente como resistência, desinteresse ou retraimento afetivo, quando às vezes reflete o custo cognitivo e motor do momento. Também é útil considerar sono ruim, dor, outras medicações sedativas e progressão do quadro neurológico antes de atribuir a mudança a um único fator.

Sono e sonhos: O sono pode ficar fragmentado, com sonolência diurna, cochilos involuntários ou relatos de sonhos vívidos, o que repercute diretamente na disponibilidade psíquica para elaborar em sessão. O terapeuta pode notar oscilação entre torpor e maior alerta, além de lapsos de atenção que lembram desmotivação. Como esse campo também sofre impacto de ansiedade, depressão, rotina doméstica e comorbidades clínicas, vale mapear padrão, horário e contexto em vez de concluir por uma causa única.

Autonomia e identidade: À medida que o tratamento se torna parte central da rotina, o paciente pode oscilar entre gratidão por manter funcionalidade e ressentimento por depender de horários, ajuda de terceiros e adaptações. Na sessão, isso costuma tocar autoestima, vergonha, sexualidade, imagem corporal e medo de se tornar um peso. Parte do sofrimento vem da condição de base e de suas perdas cumulativas, não apenas do tratamento, e essa distinção ajuda a sustentar elaboração sem reduzir tudo ao medicamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Associação usada sobretudo na doença de Parkinson e em alguns quadros parkinsonianos, geralmente em tratamento contínuo e de longa duração. No consultório de terapia, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como as oscilações motoras e não motoras ao longo do dia atravessam humor, autonomia, ritmo da sessão e senso de identidade. Mudanças podem aparecer após início ou ajustes recentes, mas também ao longo de meses e anos de tratamento, com variação entre períodos de maior fluidez e momentos de travamento, lentificação ou cansaço. Vale acompanhar a relação temporal entre funcionamento, horário das tomadas, sono, frustração e adesão.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe que está mais travado ou mais solto, isso costuma acompanhar mais o horário do dia e a rotina corporal ou acontece principalmente depois de situações emocionais específicas? , Nos dias em que você parece mais desanimado, o que pesa mais: tristeza e desesperança, ou cansaço, lentidão e frustração por não conseguir fazer o que queria? , Quando sua fala ou seu pensamento ficam mais lentos, você sente que está sem vontade de se envolver ou que até quer, mas o corpo e a cabeça não acompanham? , Esses cochilos, lapsos de atenção ou momentos de torpor aparecem em contextos previsíveis, como após refeições ou em certos horários, ou surgem mais quando você está emocionalmente sobrecarregado? , Quando você falta, atrasa ou chega muito diferente à sessão, isso costuma ter relação com piora do corpo naquele dia, com esquecimento na rotina ou com vontade de evitar o encontro?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve oscilação funcional muito marcada ao longo do dia
- com impacto claro na autonomia e no comparecimento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar melhor o padrão e sua repercussão clínica
- Quando surgem sonolência importante
- cochilos involuntários ou episódios de adormecer em situações inadequadas
- pode valer comunicar o médico pela repercussão em segurança e funcionamento
- Quando o paciente passa a omitir tomadas
- alterar por conta própria a rotina de uso ou cogita abandonar o tratamento por frustração ou efeitos percebidos
- pode valer contato com o médico para manejo coordenado da adesão
- Quando aparecem confusão nova
- piora cognitiva perceptível ou mudança comportamental incomum em relação à linha de base
- pode valer alinhar com o médico para diferenciar progressão do quadro
- intercorrência clínica e possível relação com o tratamento

Vermelho: tratar como urgência

- Confusão aguda
- desorientação
- fala muito desconexa ou rebaixamento importante do nível de consciência em relação ao habitual.: Interromper o trabalho interpretativo
- acionar familiar ou rede de apoio e buscar avaliação médica no mesmo dia
- recorrendo à emergência se necessário
- Queda recente com ferimento

Vermelho: tratar como urgência

- incapacidade súbita de se levantar ou piora motora intensa acompanhada de risco imediato no ambiente.: Priorizar segurança física
- acionar rede de apoio e encaminhar para avaliação médica urgente ou emergência conforme o contexto

Frase clínica

O ponto central é mapear como as oscilações motoras e cognitivas atravessam humor, autonomia e presença na sessão ao longo do dia.

048 CARBIDOPA MONOIDRATADA;LEVODOPA

Substância: Carbidopa Monoidratada;Levodopa.

Nomes Comerciais: Carbidopa Monoidratada + Levodopa

Uso comum

- Associação usada sobretudo na doença de Parkinson e em alguns quadros parkinsonianos, geralmente em pacientes que já convivem com limitação motora, flutuação funcional e rotina médica contínua. No consultório, o mais útil costuma ser acompanhar a relação entre horário de tomada e variações ao longo do dia: em parte dos pacientes, semanas a meses após o início ou com uso prolongado, podem surgir períodos de melhor mobilidade alternando com travamento, lentificação ou movimentos involuntários. O foco clínico não é atribuir tudo ao remédio, mas discriminar oscilação motora, humor reativo à perda de autonomia, impacto cognitivo e adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Oscilação ao longo do dia:** Alguns pacientes chegam descrevendo janelas em que se sentem mais soltos, falam com mais fluidez e conseguem se mover melhor, seguidas por períodos de travamento, lentificação ou maior dependência. Na sessão, isso pode aparecer como variação marcante entre encontros ou até dentro do mesmo atendimento, o que às vezes se confunde com ansiedade situacional, fadiga, dor ou desânimo depressivo. Vale observar se o padrão guarda relação consistente com horários, refeições e rotina, porque a leitura puramente psicológica pode superestimar instabilidade emocional quando há oscilação funcional importante.

Movimentos involuntários: Com o uso continuado, alguns pacientes passam a notar movimentos excessivos, inquietação corporal ou gestos que parecem escapar ao controle, especialmente em momentos em que a mobilidade está melhor. Em sessão, isso pode ser lido apressadamente como agitação ansiosa, tensão interpessoal ou traço de personalidade, quando às vezes o corpo está apenas mais desorganizado naquele período do dia. Também convém diferenciar de tremor basal do quadro neurológico e de inquietação ligada a desconforto emocional, registrando contexto, duração e impacto subjetivo.

Humor e reatividade: A perda de autonomia, o constrangimento com o corpo e a imprevisibilidade funcional frequentemente pesam mais no humor do que um efeito direto da medicação. Ainda assim, alguns pacientes podem parecer mais expansivos, impulsivos ou desinibidos em certos períodos, o que pede cuidado para não confundir alívio legítimo por estar se movendo melhor com mudança de estado mais ampla. O contraste entre baseline afetivo, crítica sobre o próprio comportamento e repercussão fora da sessão ajuda a separar reatividade compreensível de uma alteração que mereça ser comunicada.

Cognição e ritmo mental: Lentificação do pensamento, dificuldade de acompanhar o fio da conversa e oscilação atencional podem decorrer do próprio quadro neurológico, de sono ruim, idade, sobrecarga clínica ou de momentos de pior mobilidade. Em outros casos, o paciente chega mais acelerado, tangencial ou com menor freio associativo em determinados horários, o que pode confundir a leitura do processo terapêutico. Mais do que concluir causa, interessa mapear se a variação cognitiva acompanha o estado motor, se é nova e se compromete a capacidade de elaboração e autocuidado.

Adesão e rotina: A associação costuma entrar em rotinas rígidas, e pequenas irregularidades podem repercutir de forma perceptível no funcionamento diário. Na sessão, isso aparece como narrativa de dias muito diferentes entre si, faltas, atrasos, sensação de que 'nada funciona igual' ou abandono silencioso por frustração, náusea ou complexidade do esquema. Antes de ler como resistência ao tratamento ou desorganização psíquica, vale explorar se houve mudanças práticas na rotina, esquecimentos, dificuldade para manter horários ou interrupções por conta própria."

O que observar em sessão

- **Oscilação ao longo do dia:** Alguns pacientes chegam descrevendo janelas em que se sentem mais soltos, falam com mais fluidez e conseguem se mover melhor, seguidas por períodos de travamento, lentificação ou maior dependência. Na sessão, isso pode aparecer como variação marcante entre encontros ou até dentro do mesmo atendimento, o que às vezes se confunde com ansiedade situacional, fadiga, dor ou desânimo depressivo. Vale observar se o padrão guarda relação consistente com horários, refeições e rotina, porque a leitura puramente psicológica pode superestimar instabilidade emocional quando há oscilação funcional importante.

Movimentos involuntários: Com o uso continuado, alguns pacientes passam a notar movimentos excessivos, inquietação corporal ou gestos que parecem escapar ao controle, especialmente em momentos em que a mobilidade está melhor. Em sessão, isso pode ser lido apressadamente como agitação ansiosa, tensão interpessoal ou traço de personalidade, quando às vezes o corpo está apenas mais desorganizado naquele período do dia. Também convém diferenciar de tremor basal do quadro neurológico e de inquietação ligada a desconforto emocional, registrando contexto, duração e impacto subjetivo.

Humor e reatividade: A perda de autonomia, o constrangimento com o corpo e a imprevisibilidade funcional frequentemente pesam mais no humor do que um efeito direto da medicação. Ainda assim, alguns pacientes podem parecer mais expansivos, impulsivos ou desinibidos em certos períodos, o que pede cuidado para não confundir alívio legítimo por estar se movendo melhor com mudança de estado mais ampla. O contraste entre baseline afetivo, crítica sobre o próprio comportamento e repercussão fora da sessão ajuda a separar reatividade compreensível de uma alteração que mereça ser comunicada.

Cognição e ritmo mental: Lentificação do pensamento, dificuldade de acompanhar o fio da conversa e oscilação atencional podem decorrer do próprio quadro neurológico, de sono ruim, idade, sobrecarga clínica ou de momentos de pior mobilidade. Em outros casos, o paciente chega mais acelerado, tangencial ou com menor freio associativo em determinados horários, o que pode confundir a leitura do processo terapêutico. Mais do que concluir causa, interessa mapear se a variação cognitiva acompanha o estado motor, se é nova e se compromete a capacidade de elaboração e autocuidado.

Adesão e rotina: A associação costuma entrar em rotinas rígidas, e pequenas irregularidades podem repercutir de forma perceptível no funcionamento diário. Na sessão, isso aparece como narrativa de dias muito diferentes entre si, faltas, atrasos, sensação de que 'nada funciona igual' ou abandono silencioso por frustração, náusea ou complexidade do esquema. Antes de ler como resistência ao tratamento ou desorganização psíquica, vale explorar se houve mudanças práticas na rotina, esquecimentos, dificuldade para manter horários ou interrupções por conta própria.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Associação usada sobretudo na doença de Parkinson e em alguns quadros parkinsonianos, geralmente em pacientes que já convivem com limitação motora, flutuação funcional e rotina médica contínua. No consultório, o mais útil costuma ser acompanhar a relação entre horário de tomada e variações ao longo do dia: em parte dos pacientes, semanas a meses após o início ou com uso prolongado, podem surgir períodos de melhor mobilidade alternando com travamento, lentificação ou movimentos involuntários. O foco clínico não é atribuir tudo ao remédio, mas discriminar oscilação motora, humor reativo à perda de autonomia, impacto cognitivo e adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe que está mais travado ou mais solto, isso costuma acontecer em horários parecidos do dia ou parece depender mais do que aconteceu emocionalmente naquele dia? , Esses movimentos ou essa inquietação no corpo vêm junto com sensação de preocupação e tensão por dentro, ou aparecem mesmo quando você se sente relativamente calmo? , Nos momentos em que você fica mais animado ou falante, você se sente apenas aliviado por estar funcionando melhor ou percebe também menos freio, mais impulsividade ou atitudes fora do seu padrão? , Quando seu pensamento parece mais lento ou mais confuso, isso acompanha cansaço e piora do corpo, ou aparece mesmo em momentos em que a mobilidade está melhor? , Nos dias em que você sente uma piora mais brusca, houve alguma mudança de rotina, esquecimento, atraso ou interrupção das tomadas? , O desânimo que aparece vem mais da frustração com as limitações e dependências do dia a dia, ou você nota uma tristeza mais contínua, que permanece mesmo quando o corpo está melhor?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve oscilação muito marcada entre períodos de boa mobilidade e travamento
- com impacto funcional relevante
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a intensidade e o padrão dessas flutuações
- Quando surgem movimentos involuntários novos ou mais intensos
- especialmente se passam a constranger o paciente ou atrapalhar a sessão
- pode valer comunicar para qualificar o que está sendo observado no cotidiano
- Quando aparecem expansividade
- impulsividade
- desinibição ou redução importante da crítica fora do padrão habitual
- pode valer contato com o médico para diferenciar reatividade emocional de alteração comportamental associada ao tratamento ou ao quadro de base
- Quando a adesão parece irregular por esquecimento
- frustração
- náusea ou complexidade da rotina

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer informar o médico assistente porque a leitura clínica da resposta fica comprometida
- Quando não há benefício percebido após acompanhamento já prolongado ou há piora funcional progressiva apesar de uso referido como regular
- pode valer alinhar com o médico para atualizar o quadro observado em sessão

Vermelho: tratar como urgência

- Surge confusão importante
- desorientação
- fala muito desconexa ou alteração acentuada do estado mental acompanhada de piora física evidente.: Interromper a leitura exclusivamente psicoterápica e acionar avaliação médica no mesmo dia
- com rede de apoio e emergência se necessário
- Há queda abrupta do funcionamento
- incapacidade súbita de se mover com segurança
- ou relato de quedas repetidas com risco imediato.: Priorizar segurança
- acionar familiar ou rede de apoio presente e buscar avaliação médica urgente no mesmo dia

Frase clínica

O ponto central é mapear flutuações entre corpo, humor e rotina, sem confundir oscilação funcional com mudança psíquica primária.

049 CARBIDOPA;LEVODOPA

Substância: Carbidopa;Levodopa.

Nomes Comerciais: Carbidopa + Levodopa

Uso comum

- Carbidopa + levodopa é um tratamento central na doença de Parkinson e costuma aparecer no consultório menos pelo nome do fármaco e mais pelas oscilações do corpo e da rotina ao longo do dia. Para o terapeuta, o ponto de observação não é farmacológico, mas o padrão: períodos em que o paciente se sente mais solto e funcional alternando com momentos de lentificação, rigidez, tremor ou maior dificuldade para falar, pensar e se engajar. Essas variações podem surgir dentro do mesmo dia e, ao longo de semanas ou meses, interferir no humor, na autonomia, na autoestima e na previsibilidade da vida cotidiana. Vale acompanhar se a sessão coincide com um período de maior mobilidade ou de maior travamento, porque isso muda a leitura clínica do encontro.

O paciente pode relatar

- **"Oscilação ao longo do dia:** Alguns pacientes chegam muito diferentes de uma sessão para outra, ou até mudam durante o próprio encontro: em certos momentos estão mais soltos, com fala mais fluida e maior iniciativa; em outros, aparecem lentificados, rígidos, com mais esforço para se mover ou se expressar. Isso pode ser confundido com oscilação emocional, resistência, desinvestimento ou piora depressiva, quando às vezes acompanha mais de perto a variação motora e funcional do dia. Vale observar se o paciente consegue descrever um padrão temporal relativamente previsível ou se a experiência lhe parece caótica e difícil de antecipar.

Humor e frustração: A perda de previsibilidade corporal costuma repercutir no humor de modo importante: irritação, desânimo, vergonha, sensação de dependência e luto pela autonomia podem ganhar relevo na sessão. Em parte dos casos, o sofrimento parece acompanhar mais a limitação funcional e o constrangimento social do que um episódio depressivo estruturado; em outros, a depressão de base ou eventos de vida pesam mais do que a condição neurológica em si. O terapeuta ganha precisão quando diferencia tristeza ligada a perdas concretas, desesperança mais persistente e reatividade emocional diante dos períodos de travamento.

Cognição e ritmo: Pode haver variação no ritmo de pensamento, na atenção e na capacidade de acompanhar a conversa, especialmente quando o paciente está mais travado, cansado ou sobrecarregado pelo esforço de se mover e falar. Na sessão, isso às vezes se parece com retraimento, empobrecimento associativo ou baixa elaboração, mas nem sempre corresponde a desinteresse psíquico. Também convém considerar sono ruim, dor, outras medicações e o próprio estresse de sair de casa para comparecer ao atendimento antes de concluir que houve piora cognitiva ou afetiva.

Impulsividade e desinibição: Em uma parcela menor de pacientes, podem surgir mudanças de comportamento como maior impulsividade, busca de prazer menos habitual, gastos, jogo, sexualidade mais desinibida ou decisões pouco usuais para a linha de base. Na sessão, isso pode aparecer como euforia discreta, racionalizações, minimização de consequências ou um contraste marcante com o estilo prévio do paciente. Sem assumir causalidade, vale discriminar se se trata de alívio legítimo por estar mais funcional, traço antigo reativado por contexto de vida ou mudança comportamental nova, mais abrupta e menos crítica.

Adesão e rotina: Como a experiência subjetiva do dia pode variar bastante, alguns pacientes organizam a vida em torno dos momentos em que se sentem mais capazes, enquanto outros se desorganizam, esquecem horários ou passam a evitar compromissos por medo de travar fora de casa. Isso repercute diretamente na presença em sessão, na pontualidade, na energia disponível para o trabalho terapêutico e no sentimento de autoeficácia. Quando o padrão fica muito irregular, é útil não ler automaticamente como ambivalência com a terapia, porque adesão ao tratamento global, sobrecarga do cuidador e dificuldade prática de locomoção podem estar no centro."

O que observar em sessão

- **Oscilação ao longo do dia:** Alguns pacientes chegam muito diferentes de uma sessão para outra, ou até mudam durante o próprio encontro: em certos momentos estão mais soltos, com fala mais fluida e maior iniciativa; em outros, aparecem lentificados, rígidos, com mais esforço para se mover ou se expressar. Isso pode ser confundido com oscilação emocional, resistência, desinvestimento ou piora depressiva, quando às vezes acompanha mais de perto a variação motora e funcional do dia. Vale observar se o paciente consegue descrever um padrão temporal relativamente previsível ou se a experiência lhe parece caótica e difícil de antecipar.

Humor e frustração: A perda de previsibilidade corporal costuma repercutir no humor de modo importante: irritação, desânimo, vergonha, sensação de dependência e luto pela autonomia podem ganhar relevo na sessão. Em parte dos casos, o sofrimento parece acompanhar mais a limitação funcional e o constrangimento social do que um episódio depressivo estruturado; em outros, a depressão de base ou eventos de vida pesam mais do que a condição neurológica em si. O terapeuta ganha precisão quando diferencia tristeza ligada a perdas concretas, desesperança mais persistente e reatividade emocional diante dos períodos de travamento.

Cognição e ritmo: Pode haver variação no ritmo de pensamento, na atenção e na capacidade de acompanhar a conversa, especialmente quando o paciente está mais travado, cansado ou sobrecarregado pelo esforço de se mover e falar. Na sessão, isso às vezes se parece com retraimento, empobrecimento associativo ou baixa elaboração, mas nem sempre corresponde a desinteresse psíquico. Também convém considerar sono ruim, dor, outras medicações e o próprio estresse de sair de casa para comparecer ao atendimento antes de concluir que houve piora cognitiva ou afetiva.

Impulsividade e desinibição: Em uma parcela menor de pacientes, podem surgir mudanças de comportamento como maior impulsividade, busca de prazer menos habitual, gastos, jogo, sexualidade mais desinibida ou decisões pouco usuais para a linha de base. Na sessão, isso pode aparecer como euforia discreta, racionalizações, minimização de consequências ou um contraste marcante com o estilo prévio do paciente. Sem assumir causalidade, vale discriminar se se trata de alívio legítimo por estar mais funcional, traço antigo reativado por contexto de vida ou mudança comportamental nova, mais abrupta e menos crítica.

Adesão e rotina: Como a experiência subjetiva do dia pode variar bastante, alguns pacientes organizam a vida em torno dos momentos em que se sentem mais capazes, enquanto outros se desorganizam, esquecem horários ou passam a evitar compromissos por medo de travar fora de casa. Isso repercute diretamente na presença em sessão, na pontualidade, na energia disponível para o trabalho terapêutico e no sentimento de autoeficácia. Quando o padrão fica muito irregular, é útil não ler automaticamente como ambivalência com a terapia, porque adesão ao tratamento global, sobrecarga do cuidador e dificuldade prática de locomoção podem estar no centro.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Carbidopa + levodopa é um tratamento central na doença de Parkinson e costuma aparecer no consultório menos pelo nome do fármaco e mais pelas oscilações do corpo e da rotina ao longo do dia. Para o terapeuta, o ponto de observação não é farmacológico, mas o padrão: períodos em que o paciente se sente mais solto e funcional alternando com momentos de lentificação, rigidez, tremor ou maior dificuldade para falar, pensar e se engajar. Essas variações podem surgir dentro do mesmo dia e, ao longo de semanas ou meses, interferir no humor, na autonomia, na autoestima e na previsibilidade da vida cotidiana. Vale acompanhar se a sessão coincide com um período de maior mobilidade ou de maior travamento, porque isso muda a leitura clínica do encontro.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe que está mais travado ou mais solto, isso costuma mudar também seu humor ou primeiro muda o corpo e depois vem a reação emocional? , Nos dias em que você chega mais lento ou com mais dificuldade para falar, você se sente por dentro igualmente interessado e presente, ou é como se o pensamento também ficasse mais difícil? , Essas mudanças ao longo do dia seguem algum padrão que você reconhece, ou parecem acontecer mais em resposta a estresse, frustração ou situações interpessoais? , Esse aumento de iniciativa ou busca de prazer que apareceu recentemente parece com algo seu de longa data, ou soa como um jeito novo de agir, mais difícil de frear? , Quando você falta, desmarca ou evita sair, isso acontece mais por desânimo e vontade de se isolar, ou por receio concreto de não conseguir se mover, falar ou se virar fora de casa?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve oscilações muito marcadas de mobilidade e funcionamento ao longo do dia
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o impacto clínico dessas variações na rotina e na adesão ao cuidado
- Quando surgem impulsividade
- gastos
- jogo
- hipersexualidade ou outras condutas pouco usuais para a linha de base
- pode valer comunicar o médico para avaliação de mudança comportamental com repercussão funcional
- Quando a lentificação
- a dificuldade de fala ou a aparente confusão aumentam de modo nítido e persistente em relação ao padrão habitual
- pode valer contato com o médico para esclarecer se houve mudança clínica relevante além de fatores emocionais
- Quando o paciente passa a faltar
- evitar compromissos ou restringir muito a vida por medo de travar ou por imprevisibilidade corporal

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico porque isso pode estar comprometendo funcionalidade e continuidade do tratamento
- Quando aparecem alucinações
- ideias de perseguição ou perda importante de crítica que não faziam parte da linha de base
- pode valer comunicação com o médico assistente pela mudança do estado mental e pelo risco funcional associado

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente apresenta alucinações intensas
- forte desorganização
- medo persecutório ou perda de contato com a realidade durante a sessão.: Priorizar segurança
- acionar médico e rede de apoio no mesmo dia e considerar emergência conforme gravidade e suporte disponível
- Há ideação suicida com intenção
- plano ou incapacidade de garantir segurança
- especialmente em contexto de perda funcional acentuada e desesperança.: Fazer manejo de risco imediatamente
- acionar rede de apoio e encaminhar para avaliação urgente no mesmo dia

Frase clínica

O foco clínico é distinguir sofrimento psíquico primário da reação às oscilações motoras, cognitivas e funcionais que reorganizam o cotidiano.

050 CLORIDRATO DE BENSERAZIDA;LEVODOPA

Substância: Cloridrato de Benserazida;Levodopa.

Nomes Comerciais: Prolopa, Levodopa + Cloridrato de Benserazida, Ekson, Levodopa+Cloridrato de Benserazida, Lebens

Uso comum

- Associação dopaminérgica usada sobretudo na doença de Parkinson e, menos frequentemente, em síndromes parkinsonianas. No consultório de terapia, o foco costuma ser menos o nome do fármaco e mais como a oscilação motora e não motora atravessa humor, autonomia, ritmo da sessão e senso de identidade. Mudanças podem aparecer logo após início ou ajustes médicos, mas também ao longo do dia, com períodos em que o paciente se sente mais solto e outros em que fica mais lento, rígido ou travado. Vale acompanhar se há flutuação previsível entre sessões, piora no fim do intervalo entre tomadas, movimentos involuntários, impulsividade nova ou confusão, sem assumir que tudo decorre da medicação.

O paciente pode relatar

- **"Oscilação ao longo do dia:** Alguns pacientes chegam descrevendo janelas em que conseguem se mover, pensar e falar com mais fluidez, alternadas com períodos de travamento, lentificação ou maior dependência. Na sessão, isso pode aparecer como variação marcante de velocidade de fala, expressividade, iniciativa e tolerância à frustração, às vezes diferente do padrão afetivo habitual. O que confunde a leitura é que essas oscilações podem parecer instabilidade emocional, desânimo depressivo ou resistência ao trabalho, quando também podem acompanhar flutuações do quadro neurológico ou irregularidade no uso.

Humor e reatividade: Quando a mobilidade melhora, parte dos pacientes fica mais disponível, esperançosa e engajada; em outros momentos surgem irritabilidade, frustração intensa com perdas funcionais ou desânimo ligado à progressão da doença. Em sessão, vale notar se a reatividade emocional acompanha mudanças concretas de autonomia e corpo ou se aparece de modo mais autônomo, sustentado e pouco dependente do contexto. Eventos de vida, luto por perdas acumuladas e comorbidades depressivas ou ansiosas podem produzir quadro semelhante e não devem ser reduzidos ao tratamento medicamentoso.

Impulsividade e desinibição: Em uma parcela menor, podem surgir comportamentos mais impulsivos, busca de recompensa, gastos, jogo, aumento de sexualidade ou decisões pouco usuais para a linha de base. O terapeuta pode perceber aceleração na fala, menor freio reflexivo e justificativas ego-sintônicas para condutas recentes, o que às vezes se confunde com alívio legítimo após melhora motora ou com traços prévios de personalidade. A discriminação depende de comparar com o padrão anterior, a temporalidade de aparecimento e o impacto funcional, inclusive quando o paciente minimiza mudanças percebidas pela família.

Confusão e percepção: Sobretudo em pacientes mais velhos ou clinicamente frágeis, podem aparecer momentos de confusão, sonho muito vívido, sensação de presença, interpretações estranhas ou dificuldade maior para organizar a narrativa. Na sessão, isso pode ser sutil: perda do fio, oscilação atencional, estranhamento perceptivo ou relato de experiências que o paciente não sustenta com convicção delirante. O desafio é não confundir automaticamente com demência em progressão, privação de sono, infecção intercorrente ou efeito de outras medicações que também alteram cognição e percepção.

Movimentos involuntários: Quando o tratamento está em curso, alguns pacientes passam a relatar movimentos excessivos, contorções, inquietação corporal ou dificuldade de permanecer confortáveis, às vezes justamente nos períodos em que se sentem mais destravados. Em sessão, isso pode ser lido apressadamente como ansiedade, agitação psíquica ou impaciência, embora o corpo esteja expressando uma alteração motora mais do que um aumento de angústia. Também aqui a comparação com a baseline ajuda: o paciente descreve medo e apreensão, ou incômodo corporal sem conteúdo ansioso correspondente?

Autonomia e identidade: A resposta ao tratamento pode mexer fortemente com autoestima, dependência e lugar familiar: dias melhores ampliam projetos, enquanto dias piores recolocam limites de forma abrupta. O terapeuta costuma encontrar luto por perdas, vergonha do corpo, evitação social e tensão entre desejar autonomia e precisar de ajuda. Se isso não for contextualizado, a sessão pode ficar centrada apenas em adesão ou sintoma, perdendo o

impacto subjetivo de viver com uma condição crônica flutuante."

O que observar em sessão

- **Oscilação ao longo do dia:** Alguns pacientes chegam descrevendo janelas em que conseguem se mover, pensar e falar com mais fluidez, alternadas com períodos de travamento, lentificação ou maior dependência. Na sessão, isso pode aparecer como variação marcante de velocidade de fala, expressividade, iniciativa e tolerância à frustração, às vezes diferente do padrão afetivo habitual. O que confunde a leitura é que essas oscilações podem parecer instabilidade emocional, desânimo depressivo ou resistência ao trabalho, quando também podem acompanhar flutuações do quadro neurológico ou irregularidade no uso.

Humor e reatividade: Quando a mobilidade melhora, parte dos pacientes fica mais disponível, esperançosa e engajada; em outros momentos surgem irritabilidade, frustração intensa com perdas funcionais ou desânimo ligado à progressão da doença. Em sessão, vale notar se a reatividade emocional acompanha mudanças concretas de autonomia e corpo ou se aparece de modo mais autônomo, sustentado e pouco dependente do contexto. Eventos de vida, luto por perdas acumuladas e comorbidades depressivas ou ansiosas podem produzir quadro semelhante e não devem ser reduzidos ao tratamento medicamentoso.

Impulsividade e desinibição: Em uma parcela menor, podem surgir comportamentos mais impulsivos, busca de recompensa, gastos, jogo, aumento de sexualidade ou decisões pouco usuais para a linha de base. O terapeuta pode perceber aceleração na fala, menor freio reflexivo e justificativas ego-sintônicas para condutas recentes, o que às vezes se confunde com alívio legítimo após melhora motora ou com traços prévios de personalidade. A discriminação depende de comparar com o padrão anterior, a temporalidade de aparecimento e o impacto funcional, inclusive quando o paciente minimiza mudanças percebidas pela família.

Confusão e percepção: Sobretudo em pacientes mais velhos ou clinicamente frágeis, podem aparecer momentos de confusão, sonho muito vívido, sensação de presença, interpretações estranhas ou dificuldade maior para organizar a narrativa. Na sessão, isso pode ser sutil: perda do fio, oscilação atencional, estranhamento perceptivo ou relato de experiências que o paciente não sustenta com convicção delirante. O desafio é não confundir automaticamente com demência em progressão, privação de sono, infecção intercorrente ou efeito de outras medicações que também alteram cognição e percepção.

Movimentos involuntários: Quando o tratamento está em curso, alguns pacientes passam a relatar movimentos excessivos, contorções, inquietação corporal ou dificuldade de permanecer confortáveis, às vezes justamente nos períodos em que se sentem mais destravados. Em sessão, isso pode ser lido apressadamente como ansiedade, agitação psíquica ou impaciência, embora o corpo esteja expressando uma alteração motora mais do que um aumento de angústia. Também aqui a comparação com a baseline ajuda: o paciente descreve medo e apreensão, ou incômodo corporal sem conteúdo ansioso correspondente?

Autonomia e identidade: A resposta ao tratamento pode mexer fortemente com autoestima, dependência e lugar familiar: dias melhores ampliam projetos, enquanto dias piores recolocam limites de forma abrupta. O terapeuta costuma encontrar luto por perdas, vergonha do corpo, evitação social e tensão entre desejar autonomia e precisar de ajuda. Se isso não for contextualizado, a sessão pode ficar centrada apenas em adesão ou sintoma, perdendo o

impacto subjetivo de viver com uma condição crônica flutuante.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Associação dopaminérgica usada sobretudo na doença de Parkinson e, menos frequentemente, em síndromes parkinsonianas. No consultório de terapia, o foco costuma ser menos o nome do fármaco e mais como a oscilação motora e não motora atravessa humor, autonomia, ritmo da sessão e senso de identidade. Mudanças podem aparecer logo após início ou ajustes médicos, mas também ao longo do dia, com períodos em que o paciente se sente mais solto e outros em que fica mais lento, rígido ou travado. Vale acompanhar se há flutuação previsível entre sessões, piora no fim do intervalo entre tomadas, movimentos involuntários, impulsividade nova ou confusão, sem assumir que tudo decorre da medicação.

Perguntas úteis

- "Quando você fica mais travado ou mais solto, isso costuma acontecer em horários parecidos do dia ou parece depender mais do que aconteceu emocionalmente naquele dia? , Esses movimentos ou essa inquietação no corpo vêm junto com medo, preocupação e pensamentos acelerados, ou aparecem mesmo quando você se sente relativamente calmo por dentro? , Essa fase em que você está mais ativo e decidido parece uma retomada do seu jeito habitual, ou pessoas próximas têm estranhado você por estar mais impulsivo ou sem freio? , Quando sua atenção falha ou você se confunde, isso acontece em episódios que vão e voltam, ou é uma dificuldade mais contínua ao longo dos dias? , A queda de humor aparece principalmente depois de momentos em que o corpo limita você, ou permanece mesmo em dias em que sua mobilidade está melhor? , Quando você evita sair ou encontrar pessoas, o que pesa mais: receio do olhar sobre o corpo, cansaço, dificuldade prática de locomoção ou perda de interesse nas relações?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar períodos previsíveis de piora motora ou grande oscilação entre momentos de destravamento e travamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a flutuação funcional no acompanhamento clínico
- Quando surgem gastos incomuns
- jogo
- aumento importante de impulsividade ou sexualidade fora da linha de base
- pode valer comunicar o médico pela mudança comportamental com potencial de dano e baixa crítica
- Quando aparecem confusão nova
- experiências perceptivas incomuns ou desorganização que não eram do padrão do paciente
- pode valer contato com o médico para diferenciar agravamento clínico
- intercorrência e possível relação com o tratamento em curso
- Quando movimentos involuntários ou inquietação corporal passam a constranger o paciente

Amarelo: alinhar em breve

- atrapalhar a sessão ou reduzir adesão ao tratamento
- pode valer alinhar com o médico pelo impacto funcional e risco de abandono silencioso
- Quando o paciente interrompe
- esquece com frequência ou usa de modo muito irregular por conta própria
- pode valer comunicar o médico porque a leitura da evolução clínica fica mais difícil e a oscilação funcional tende a aumentar

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente chega muito confuso
- não sustenta a atenção
- parece desorientado ou relata ver pessoas
- bichos ou cenas que os demais não veem
- com prejuízo importante de contato com a realidade.: Interromper o foco habitual da sessão
- avaliar segurança imediata e acionar no mesmo dia o médico assistente
- rede de apoio ou emergência conforme gravidade
- Surge agitação intensa com impulsividade acentuada
- redução importante do juízo crítico e risco concreto de se expor
- gastar muito ou colocar-se em perigo.: Priorizar contenção e segurança
- envolver rede de apoio e buscar contato médico no mesmo dia; se houver risco iminente
- acionar emergência

Frase clínica

O ponto central é distinguir sofrimento psíquico de flutuação motora e comportamental, sem perder de vista autonomia, identidade e risco.

051 CLORIDRATO DE BIPERIDENO

Substância: Cloridrato de Biperideno.

Nomes Comerciais: Cinetol, Propark, Akineton

Uso comum

- O cloridrato de biperideno é um anticolinérgico usado, em geral, para manejar rigidez, tremor, lentificação e outros efeitos extrapiramidais associados a antipsicóticos ou a quadros parkinsonianos. No consultório de terapia, costuma aparecer menos como tema central e mais como peça de um arranjo medicamentoso já complexo. Mudanças podem surgir nos primeiros dias após início ou ajuste do esquema em que ele está inserido, e a observação clínica ganha valor quando há oscilação entre melhora motora e custo subjetivo em atenção, memória, boca seca, constipação, visão turva ou sonolência. O ponto central na sessão é discriminar se a mudança no funcionamento decorre mais do quadro de base, do antipsicótico em uso, do próprio biperideno, de adesão irregular ou de sobrecarga clínica geral.

O paciente pode relatar

- **"Cognição e atenção:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter mais dispersão, lentificação para acompanhar raciocínios, dificuldade de recuperar palavras ou de sustentar elaboração mais complexa. Isso pode ser lido apressadamente como piora psicótica, depressiva ou desorganização basal, quando às vezes aparece junto de um esquema medicamentoso mais carregado ou de uso irregular. Vale comparar com a linha de base recente e observar se a oscilação cognitiva acompanha horários de tomada, dias de esquecimento, privação de sono ou aumento global de sedação por outras medicações.

Sedação e ritmo: Alguns pacientes chegam mais sonolentos, menos responsivos ou com queda do ritmo associativo, o que pode reduzir acesso afetivo e produtividade da sessão. Esse padrão pode se confundir com retraimento depressivo, efeito residual de antipsicóticos, uso de benzodiazepínicos, noites mal dormidas ou exaustão pela própria condição clínica. A discriminação costuma depender de notar se há sonolência corporal e embotamento flutuante, em contraste com tristeza mais consistente, anedonia ou desesperança.

Sintomas físicos específicos: Boca seca, constipação, visão turva e desconforto corporal podem entrar na sessão como queixas secundárias, mas às vezes passam a organizar humor, irritabilidade e adesão silenciosamente. O terapeuta pode notar maior consumo de água, incômodo para falar, dificuldade de leitura de anotações ou impaciência corporal sem que isso seja nomeado de início. Como esses sinais também podem decorrer de outros psicofármacos, baixa hidratação, ansiedade ou condições clínicas intercorrentes, vale situar início, intensidade e impacto funcional antes de atribuir sentido ao quadro.

Adesão e uso irregular: Como o biperideno costuma entrar para aliviar efeitos incômodos de outro medicamento, o paciente pode usá-lo de modo irregular, esquecer doses ou abandoná-lo sem comentar, sobretudo quando percebe melhora motora e minimiza o restante do esquema. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação entre dias com mais rigidez, tremor, inquietação ou desconforto corporal e dias mais estáveis, sem narrativa clara de mudança emocional correspondente. A leitura clínica fica confusa quando o paciente também ajusta por conta própria o antipsicótico, usa medicações PRN ou tem rotina muito desorganizada.

Leitura do quadro de base: Uma melhora de rigidez, tremor ou travamento pode ampliar presença na sessão, contato ocular e espontaneidade, o que às vezes parece melhora global do quadro psiquiátrico quando a mudança é mais motora do que afetiva. No sentido oposto, piora de desconforto corporal pode ser tomada como ansiedade primária ou agitação psíquica. O trabalho do terapeuta é separar, tanto quanto possível, o que mudou no corpo, no pensamento e no vínculo, sem supor que todos os eixos evoluem juntos."

O que observar em sessão

- **Cognição e atenção:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter mais dispersão, lentificação para acompanhar raciocínios, dificuldade de recuperar palavras ou de sustentar elaboração mais complexa. Isso pode ser lido apressadamente como piora psicótica, depressiva ou desorganização basal, quando às vezes aparece junto de um esquema medicamentoso mais carregado ou de uso irregular. Vale comparar com a linha de base recente e observar se a oscilação cognitiva acompanha horários de tomada, dias de esquecimento, privação de sono ou aumento global de sedação por outras medicações.

Sedação e ritmo: Alguns pacientes chegam mais sonolentos, menos responsivos ou com queda do ritmo associativo, o que pode reduzir acesso afetivo e produtividade da sessão. Esse padrão pode se confundir com retraimento depressivo, efeito residual de antipsicóticos, uso de benzodiazepínicos, noites mal dormidas ou exaustão pela própria condição clínica. A discriminação costuma depender de notar se há sonolência corporal e embotamento flutuante, em contraste com tristeza mais consistente, anedonia ou desesperança.

Sintomas físicos específicos: Boca seca, constipação, visão turva e desconforto corporal podem entrar na sessão como queixas secundárias, mas às vezes passam a organizar humor, irritabilidade e adesão silenciosamente. O terapeuta pode notar maior consumo de água, incômodo para falar, dificuldade de leitura de anotações ou impaciência corporal sem que isso seja nomeado de início. Como esses sinais também podem decorrer de outros psicofármacos, baixa hidratação, ansiedade ou condições clínicas intercorrentes, vale situar início, intensidade e impacto funcional antes de atribuir sentido ao quadro.

Adesão e uso irregular: Como o biperideno costuma entrar para aliviar efeitos incômodos de outro medicamento, o paciente pode usá-lo de modo irregular, esquecer doses ou abandoná-lo sem comentar, sobretudo quando percebe melhora motora e minimiza o restante do esquema. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação entre dias com mais rigidez, tremor, inquietação ou desconforto corporal e dias mais estáveis, sem narrativa clara de mudança emocional correspondente. A leitura clínica fica confusa quando o paciente também ajusta por conta própria o antipsicótico, usa medicações PRN ou tem rotina muito desorganizada.

Leitura do quadro de base: Uma melhora de rigidez, tremor ou travamento pode ampliar presença na sessão, contato ocular e espontaneidade, o que às vezes parece melhora global do quadro psiquiátrico quando a mudança é mais motora do que afetiva. No sentido oposto, piora de desconforto corporal pode ser tomada como ansiedade primária ou agitação psíquica. O trabalho do terapeuta é separar, tanto quanto possível, o que mudou no corpo, no pensamento e no vínculo, sem supor que todos os eixos evoluem juntos.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O cloridrato de biperideno é um anticolinérgico usado, em geral, para manejar rigidez, tremor, lentificação e outros efeitos extrapiramidais associados a antipsicóticos ou a quadros parkinsonianos. No consultório de terapia, costuma aparecer menos como tema central e mais como peça de um arranjo medicamentoso já complexo. Mudanças podem surgir nos primeiros dias após início ou ajuste do esquema em que ele está inserido, e a observação clínica ganha valor quando há oscilação entre melhora motora e custo subjetivo em atenção, memória, boca seca, constipação, visão turva ou sonolência. O ponto central na sessão é discriminar se a mudança no funcionamento decorre mais do quadro de base, do antipsicótico em uso, do próprio biperideno, de adesão irregular ou de sobrecarga clínica geral.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais travado, inquieto ou tremendo, isso vem junto de medo e pensamentos acelerados, ou parece mais um desconforto corporal sem conteúdo emocional claro? , Essa dificuldade de concentração aparece como sono e cabeça pesada, ou como preocupação demais e dificuldade de desligar? , Nos dias em que você se percebe mais presente na sessão, mudou também seu humor e interesse pelas coisas, ou principalmente seu corpo ficou mais solto e menos rígido? , Quando esquece ou muda algum remédio, você nota diferença primeiro no corpo, no pensamento ou no humor? , Esse incômodo com boca seca, intestino preso ou visão embaçada está só como desconforto físico, ou já está fazendo você evitar sair, trabalhar, ler ou manter a rotina?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- reduzir adesão ou cogitar interromper medicações por desconfortos físicos ou sedação
- pode valer alinhar com o médico assistente para evitar abandono silencioso do esquema
- Quando surgem piora importante de atenção
- confusão ou queda funcional nova após mudança recente no tratamento
- pode valer comunicar o médico para ajudar a discriminar efeito medicamentoso de evolução do quadro
- Quando a sessão mostra oscilação marcada entre melhora motora e piora subjetiva relevante
- pode valer alinhar com o médico para contextualizar o impacto clínico do arranjo medicamentoso no cotidiano
- Quando o paciente descreve retorno de rigidez
- tremor
- travamento ou inquietação corporal em paralelo a uso irregular
- pode valer comunicar o médico para qualificar a leitura da adesão e do risco de descontinuidade
- Quando sintomas físicos persistentes passam a organizar humor
- sono ou funcionamento diário

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico assistente para integrar o impacto subjetivo ao acompanhamento clínico

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente chega muito confuso
- desorientado
- com fala desconexa nova ou rebaixamento importante do nível de alerta.: Interromper a lógica habitual da sessão e acionar avaliação médica no mesmo dia
- com rede de apoio e emergência se necessário
- Surge incapacidade súbita de urinar
- dor importante
- mal-estar acentuado ou agravamento físico relevante junto de confusão ou sonolência marcada.: Orientar busca de avaliação médica imediata e acionar rede de apoio se houver dificuldade de locomoção ou de julgamento

Frase clínica

O foco é separar melhora ou piora motora do custo subjetivo em cognição, sedação e adesão dentro de um esquema medicamentoso mais amplo.

052 CLORIDRATO DE SELEGILINA

Substância: Cloridrato de Selegilina.

Nomes Comerciais: Jumexil

Uso comum

- Cloridrato de selegilina é um medicamento menos frequente no consultório de psicoterapia, usado sobretudo em doença de Parkinson e, em alguns contextos, em manejo de sintomas depressivos. Para o terapeuta, costuma importar menos a farmacologia e mais a mudança no padrão subjetivo após início, retomada ou uso irregular: nas primeiras 1 a 3 semanas vale observar se surgem alteração de sono, maior ativação, irritabilidade ou inquietação; ao longo de algumas semanas, também podem aparecer oscilação entre mais iniciativa e maior impulsividade. O ponto central em sessão é diferenciar melhora legítima de energia e engajamento de aceleração pouco habitual, além de notar se o tratamento da condição de base está reorganizando rotina, autonomia e identidade.

O paciente pode relatar

- **"Ativação:** Alguns pacientes passam a chegar mais acelerados, com fala mais rápida, maior iniciativa ou sensação de estar "ligados", o que pode ser vivido como melhora ou como desconforto. Em sessão, vale notar se isso amplia elaboração e presença ou se reduz escuta, tolerância à frustração e capacidade reflexiva. A leitura pode se confundir com alívio depressivo, entusiasmo por eventos de vida, traços prévios de temperamento ou uso irregular que produz dias muito diferentes entre si.

Sono e ritmo: Insônia inicial, sono mais leve ou mudança no horário de dormir podem aparecer e repercutir diretamente na qualidade da sessão, com mais cansaço, irritabilidade ou oscilação atencional. Quando o paciente descreve estar mais desperto, convém discriminar se houve ganho funcional sustentado ou apenas redução do sono com aumento de reatividade. Também entram como confundidores dor, progressão da doença de base, ansiedade antecipatória e outras medicações em uso.

Humor e irritabilidade: Pode haver melhora do humor com mais disposição, mas em parte dos casos o consultório capta antes uma borda de impaciência, irritabilidade ou menor freio para respostas impulsivas. O terapeuta observa isso no tom, na tolerância a contratempos e na forma como o paciente lida com limites da sessão. Esse quadro pode se misturar com frustração ligada à doença crônica, conflitos familiares, piora motora, privação de sono ou expectativa excessiva de recuperação.

Cognição e atenção: Alguns pacientes relatam mais clareza e iniciativa mental; outros chegam mais dispersos, tangenciais ou com dificuldade de sustentar um fio associativo. Na sessão, importa menos nomear a causa e mais comparar com a baseline: houve ganho de presença psíquica ou uma aceleração que empobrece a reflexão? A interpretação pode ser confundida por flutuação cognitiva da condição neurológica, fadiga, humor, dor, envelhecimento e sobrecarga de tratamento.

Adesão e rotina: Como costuma aparecer em pacientes com tratamento clínico contínuo, a adesão irregular pode se manifestar menos como confissão espontânea e mais como mudanças abruptas no padrão da semana, oscilação de energia ou relato vago sobre horários e esquecimentos. Em sessão, vale observar se o paciente associa as mudanças ao contexto de vida ou se há lacunas na narrativa que sugerem uso inconsistente. Isso pode ser confundido com flutuação própria da doença de base, múltiplos remédios, dependência de cuidadores ou dificuldade executiva."

O que observar em sessão

- **Ativação:** Alguns pacientes passam a chegar mais acelerados, com fala mais rápida, maior iniciativa ou sensação de estar “ligados”, o que pode ser vivido como melhora ou como desconforto. Em sessão, vale notar se isso amplia elaboração e presença ou se reduz escuta, tolerância à frustração e capacidade reflexiva. A leitura pode se confundir com alívio depressivo, entusiasmo por eventos de vida, traços prévios de temperamento ou uso irregular que produz dias muito diferentes entre si.

Sono e ritmo: Insônia inicial, sono mais leve ou mudança no horário de dormir podem aparecer e repercutir diretamente na qualidade da sessão, com mais cansaço, irritabilidade ou oscilação atencional. Quando o paciente descreve estar mais desperto, convém discriminar se houve ganho funcional sustentado ou apenas redução do sono com aumento de reatividade. Também entram como confundidores dor, progressão da doença de base, ansiedade antecipatória e outras medicações em uso.

Humor e irritabilidade: Pode haver melhora do humor com mais disposição, mas em parte dos casos o consultório capta antes uma borda de impaciência, irritabilidade ou menor freio para respostas impulsivas. O terapeuta observa isso no tom, na tolerância a contratempos e na forma como o paciente lida com limites da sessão. Esse quadro pode se misturar com frustração ligada à doença crônica, conflitos familiares, piora motora, privação de sono ou expectativa excessiva de recuperação.

Cognição e atenção: Alguns pacientes relatam mais clareza e iniciativa mental; outros chegam mais dispersos, tangenciais ou com dificuldade de sustentar um fio associativo. Na sessão, importa menos nomear a causa e mais comparar com a baseline: houve ganho de presença psíquica ou uma aceleração que empobrece a reflexão? A interpretação pode ser confundida por flutuação cognitiva da condição neurológica, fadiga, humor, dor, envelhecimento e sobrecarga de tratamento.

Adesão e rotina: Como costuma aparecer em pacientes com tratamento clínico contínuo, a adesão irregular pode se manifestar menos como confissão espontânea e mais como mudanças abruptas no padrão da semana, oscilação de energia ou relato vago sobre horários e esquecimentos. Em sessão, vale observar se o paciente associa as mudanças ao contexto de vida ou se há lacunas na narrativa que sugerem uso inconsistente. Isso pode ser confundido com flutuação própria da doença de base, múltiplos remédios, dependência de cuidadores ou dificuldade executiva.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Cloridrato de selegilina é um medicamento menos frequente no consultório de psicoterapia, usado sobretudo em doença de Parkinson e, em alguns contextos, em manejo de sintomas depressivos. Para o terapeuta, costuma importar menos a farmacologia e mais a mudança no padrão subjetivo após início, retomada ou uso irregular: nas primeiras 1 a 3 semanas vale observar se surgem alteração de sono, maior ativação, irritabilidade ou inquietação; ao longo de algumas semanas, também podem aparecer oscilação entre mais iniciativa e maior impulsividade. O ponto central em sessão é diferenciar melhora legítima de energia e engajamento de aceleração pouco habitual, além de notar se o tratamento da condição de base está reorganizando rotina, autonomia e identidade.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente com mais energia, isso vem junto de mais clareza e organização ou de pressa, irritação e dificuldade de frear? , Essa mudança no seu sono tem sido acompanhada de bem-estar durante o dia ou de cansaço, impaciência e cabeça acelerada? , Nos dias em que você parece diferente, isso costuma acontecer de modo contínuo ao longo da semana ou varia conforme horários, esquecimentos e mudanças na rotina? , Quando você fala em melhora, você se percebe mais disponível para pensar e sentir ou mais rápido, mas com menos profundidade e mais impulsividade? , Essa irritação apareceu junto com alguma mudança corporal ou de sono, ou faz mais sentido para você como reação ao que está vivendo? , Você nota que sua atenção está melhor porque consegue sustentar melhor uma conversa, ou porque está pulando mais rápido de um assunto para outro?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a mostrar aceleração pouco habitual
- irritabilidade crescente e redução importante do sono
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se há relação temporal com o tratamento e necessidade de reavaliação
- Quando surgem oscilações marcadas entre dias muito produtivos e dias de queda
- especialmente com narrativa confusa sobre horários ou esquecimentos
- pode valer comunicar o médico para situar possível adesão irregular
- Quando a sessão passa a ser repetidamente atravessada por inquietação
- impulsividade ou piora da tolerância emocional após início recente ou retomada
- pode ser útil alinhar com o médico para contextualizar a mudança de baseline
- Quando o paciente relata piora importante do sono ou irritabilidade que começa a comprometer funcionamento
- vínculo ou continuidade do tratamento psicoterápico
- pode valer contato com o médico assistente
- Quando não se observa ganho funcional após algumas semanas e o paciente descreve frustração crescente com o tratamento da condição de base

Amarelo: alinhar em breve

- pode ser útil comunicar o médico para compartilhar o impacto clínico percebido em sessão

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecimento de ideias de morte ou autoagressão com aumento recente de agitação
- desesperança ou sensação de perda de controle.: Fazer manejo de risco na hora
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário
- Mudança abrupta para estado de grande aceleração
- pouca necessidade de sono
- comportamento desorganizado ou claramente fora do padrão habitual do paciente.: Interromper a leitura como simples melhora
- avaliar segurança imediata e acionar o médico assistente no mesmo dia
- com suporte emergencial se houver risco

Frase clínica

O foco clínico é distinguir ganho funcional real de aceleração pouco habitual, especialmente quando sono, irritabilidade e adesão começam a oscilar.

053 CLORIDRATO DE TRIEXIFENIDIL

Substância: Cloridrato de Triexifenidil.

Nomes Comerciais: Artane

Uso comum

- O cloridrato de triexifenidil é um anticolinérgico usado sobretudo para sintomas extrapiramidais associados a antipsicóticos e, em alguns casos, no parkinsonismo. No consultório, ele costuma aparecer menos como tema principal e mais como pano de fundo quando o paciente relata mudança em rigidez, tremor, inquietação corporal ou efeitos incômodos do tratamento psiquiátrico. Quando há introdução ou ajuste recente, diferenças podem surgir em poucos dias; ao longo de 1 a 2 semanas, vale observar se houve alívio motor às custas de lentificação, confusão subjetiva ou piora de memória. O ponto central na sessão é distinguir melhora de efeitos motores de um possível custo cognitivo, autonômico ou de adesão.

O paciente pode relatar

- **"Cognição:** Pode surgir sensação de cabeça mais lenta, dificuldade para encontrar palavras, lapsos de memória recente ou maior confusão, especialmente em pacientes mais velhos ou já vulneráveis cognitivamente. Na sessão, isso pode aparecer como perda do fio, respostas mais vagas ou necessidade de repetição. A leitura pode se confundir com sedação de outros psicofármacos, piora depressiva, privação de sono ou desorganização do quadro de base, por isso vale comparar com a linha de base e com o momento em que essas mudanças começaram.

Sintomas motores: Alguns pacientes chegam referindo menos rigidez, tremor ou travamento corporal, enquanto outros mantêm inquietação ou descrevem desconforto motor de forma pouco diferenciada. Na observação clínica, interessa notar se o corpo parece mais solto, menos travado, ou se persiste uma agitação que o paciente vive como ansiedade. Isso pode confundir a leitura da sessão: melhora de parkinsonismo induzido por antipsicótico não é o mesmo que redução de acatisia, e inquietação corporal também pode acompanhar ansiedade, uso irregular de medicação ou mudanças recentes no antipsicótico principal.

Boca seca e constipação: Boca seca, sede constante, dificuldade para falar longamente, desconforto para engolir e intestino preso podem aparecer de modo suficientemente incômodo para afetar humor, presença em sessão e adesão silenciosa. O terapeuta pode notar pausas frequentes para beber água, fala mais pastosa ou irritabilidade associada ao desconforto físico. Esses sinais também podem ser atribuídos pelo paciente a ansiedade, baixa ingestão de água, dieta, outras medicações com efeito semelhante ou ao próprio antipsicótico, então a discriminação depende de temporalidade e conjunto de sintomas.

Visão e leitura: Visão embaçada, dificuldade para focar e cansaço ao ler ou usar telas podem repercutir em trabalho, estudo e sensação de incompetência recente. Em sessão, isso às vezes aparece como evitação de tarefas, redução de leitura entre sessões ou queixa inespecífica de não render. Pode ser confundido com desatenção, piora ansiosa, fadiga depressiva ou sobrecarga cotidiana; por isso ajuda perguntar se a dificuldade é mais mental ou visual e se piorou junto com outros sinais físicos.

Adesão silenciosa: Como o triexifenidil costuma entrar para aliviar efeitos desagradáveis de outro tratamento, o paciente pode usá-lo de modo irregular, esquecer tomadas ou abandonar sem mencionar, sobretudo se percebe pouco benefício ou se os efeitos incômodos ganham destaque. Na sessão, isso pode aparecer como narrativa oscilante sobre dias bons e ruins, sem clareza do que mudou, ou como ambivalência em relação ao tratamento como um todo. Também é fácil atribuir essas oscilações apenas ao quadro psiquiátrico, quando parte delas pode estar ligada a uso inconsistente ou a mudanças recentes em outras medicações."

O que observar em sessão

- **Cognição:** Pode surgir sensação de cabeça "mais lenta", dificuldade para encontrar palavras, lapsos de memória recente ou maior confusão, especialmente em pacientes mais velhos ou já vulneráveis cognitivamente. Na sessão, isso pode aparecer como perda do fio, respostas mais vagas ou necessidade de repetição. A leitura pode se confundir com sedação de outros psicofármacos, piora depressiva, privação de sono ou desorganização do quadro de base, por isso vale comparar com a linha de base e com o momento em que essas mudanças começaram.

Sintomas motores: Alguns pacientes chegam referindo menos rigidez, tremor ou travamento corporal, enquanto outros mantêm inquietação ou descrevem desconforto motor de forma pouco diferenciada. Na observação clínica, interessa notar se o corpo parece mais solto, menos travado, ou se persiste uma agitação que o paciente vive como ansiedade. Isso pode confundir a leitura da sessão: melhora de parkinsonismo induzido por antipsicótico não é o mesmo que redução de acatisia, e inquietação corporal também pode acompanhar ansiedade, uso irregular de medicação ou mudanças recentes no antipsicótico principal.

Boca seca e constipação: Boca seca, sede constante, dificuldade para falar longamente, desconforto para engolir e intestino preso podem aparecer de modo suficientemente incômodo para afetar humor, presença em sessão e adesão silenciosa. O terapeuta pode notar pausas frequentes para beber água, fala mais pastosa ou irritabilidade associada ao desconforto físico. Esses sinais também podem ser atribuídos pelo paciente a ansiedade, baixa ingestão de água, dieta, outras medicações com efeito semelhante ou ao próprio antipsicótico, então a discriminação depende de temporalidade e conjunto de sintomas.

Visão e leitura: Visão embaçada, dificuldade para focar e cansaço ao ler ou usar telas podem repercutir em trabalho, estudo e sensação de incompetência recente. Em sessão, isso às vezes aparece como evitação de tarefas, redução de leitura entre sessões ou queixa inespecífica de "não render". Pode ser confundido com desatenção, piora ansiosa, fadiga depressiva ou sobrecarga cotidiana; por isso ajuda perguntar se a dificuldade é mais mental ou visual e se piorou junto com outros sinais físicos.

Adesão silenciosa: Como o triexifenidil costuma entrar para aliviar efeitos desagradáveis de outro tratamento, o paciente pode usá-lo de modo irregular, esquecer tomadas ou abandonar sem mencionar, sobretudo se percebe pouco benefício ou se os efeitos incômodos ganham destaque. Na sessão, isso pode aparecer como narrativa oscilante sobre dias "bons" e "ruins", sem clareza do que mudou, ou como ambivalência em relação ao tratamento como um todo. Também é fácil atribuir essas oscilações apenas ao quadro psiquiátrico, quando parte delas pode estar ligada a uso inconsistente ou a mudanças recentes em outras medicações.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O cloridrato de triexifenidil é um anticolinérgico usado sobretudo para sintomas extrapiramidais associados a antipsicóticos e, em alguns casos, no parkinsonismo. No consultório, ele costuma aparecer menos como tema principal e mais como pano de fundo quando o paciente relata mudança em rigidez, tremor, inquietação corporal ou efeitos incômodos do tratamento psiquiátrico. Quando há introdução ou ajuste recente, diferenças podem surgir em poucos dias; ao longo de 1 a 2 semanas, vale observar se houve alívio motor às custas de lentificação, confusão subjetiva ou piora de memória. O ponto central na sessão é distinguir melhora de efeitos motores de um possível custo cognitivo, autonômico ou de adesão.

Perguntas úteis

- "Quando essa sensação de lentidão ou confusão aparece, você percebe mais como sono, como dificuldade de pensar ou como esquecimento do que estava fazendo? , Nos dias em que o corpo incomoda mais, isso se parece com ansiedade por dentro, com necessidade de se mexer, ou com rigidez e travamento do movimento? , Essa queda no rendimento tem mais cara de desânimo e falta de iniciativa, ou de dificuldade visual e mental para sustentar leitura e atenção? , Você notou se os dias em que a boca seca, a visão ruim ou o intestino preso pioram são também os dias em que pensa em evitar ou esquecer a medicação? , Comparando com antes dessa medicação entrar, o que melhorou no corpo e o que parece ter ficado mais difícil na sua cabeça ou na sua rotina?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve melhora motora parcial
- mas passa a apresentar confusão
- lapsos de memória ou queda funcional perceptível
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar benefício motor de custo cognitivo relevante
- Quando a inquietação corporal persiste e o paciente a nomeia como ansiedade sem clareza
- pode valer alinhar com o psiquiatra para discriminar se o desconforto motor segue ativo apesar do tratamento
- Quando boca seca
- constipação ou visão embaçada começam a motivar uso irregular ou abandono silencioso
- pode valer alinhar com o psiquiatra para prevenir ruptura de adesão
- Quando surgem oscilações importantes entre dias muito travados e dias aparentemente melhores
- sem explicação clara por eventos de vida
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisar a leitura do quadro e da regularidade do uso

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- aparece confusão acentuada de instalação recente
- fala muito desconexa
- desorientação ou rebaixamento importante da responsividade.: Interromper o enquadre habitual
- acionar avaliação médica no mesmo dia e mobilizar rede de apoio ou emergência conforme o grau de comprometimento
- O paciente refere incapacidade de urinar acompanhada de dor ou distensão
- ou mal-estar físico importante junto de confusão e piora rápida do estado geral.: Orientar busca de atendimento médico imediato e
- se necessário
- acionar acompanhante
- rede de apoio ou serviço de urgência naquele momento

Frase clínica

O foco é pesar alívio de sintomas motores contra possível custo cognitivo, desconforto físico e adesão silenciosamente frágil.

054 DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL

Substância: Dicloridrato de Pramipexol.

Nomes Comerciais: Dicloridrato de Pramipexol, Pisa, Quera Lp, Sifrol, Minérgi, Stabil, Rocky

Uso comum

- O dicloridrato de pramipexol é um agonista dopaminérgico usado sobretudo na doença de Parkinson e na síndrome das pernas inquietas. No consultório de terapia, costuma aparecer menos pelo nome do fármaco e mais por mudanças em impulso, sono, energia, rotina e relação com o próprio corpo e com a doença de base. Alterações subjetivas podem surgir nas primeiras semanas após início ou mudança recente do tratamento, e oscilações ao longo do dia podem se confundir com progressão do quadro neurológico, privação de sono, dor, outras medicações ou adesão irregular. O ponto central na sessão é discriminar se houve mudança de padrão comportamental, especialmente em controle de impulsos, sonolência e organização da vida cotidiana.

O paciente pode relatar

- **"Impulsos e controle:** Em parte dos pacientes, podem surgir compras excessivas, aumento de jogo, sexualidade mais impulsiva, busca de recompensa ou decisões pouco usuais para a linha de base. Na sessão, isso às vezes aparece como racionalização, menor crítica sobre consequências ou relato de comportamentos que o paciente descreve como "mais automáticos" do que propriamente desejados. Vale diferenciar de reação a estresse, traços prévios de personalidade, episódio de humor elevado ou alívio legítimo de apatia associada à condição de base.

Sono e sonolência: Sonolência diurna, cochilos involuntários e sensação de rebaixamento de alerta podem interferir no ritmo da sessão, na atenção sustentada e na capacidade de elaboração. Em alguns casos, o paciente parece mais lento ou menos responsivo sem que isso corresponda a piora depressiva. Convém observar se o padrão começou após mudança recente no tratamento, se varia conforme o horário, e se também pode estar sendo influenciado por noites ruins, dor, benzodiazepínicos, outros sedativos ou exaustão pela doença.

Ativação e humor: Alguns pacientes descrevem mais energia, inquietação, redução da necessidade percebida de descanso ou sensação de estar "ligado", o que pode ser vivido como melhora inicial. Na sessão, a diferença entre ativação medicamentosa, ansiedade, alívio de lentificação motora e uma possível virada de humor depende do grau de aceleração, da expansividade, da autocrítica e do impacto funcional. Eventos de vida positivos, retomada de autonomia e flutuações do quadro neurológico também podem confundir essa leitura.

Percepção e realidade: Podem aparecer experiências incomuns, estranheza perceptiva, sensação de presença, sonhos muito vívidos ou interpretações menos ancoradas no habitual, sobretudo em pacientes mais vulneráveis ou com doença neurológica avançada. Na sessão, isso pode surgir de modo hesitante, com vergonha ou medo de parecer "louco", o que pede escuta concreta e sem confronto. É importante não atribuir automaticamente ao medicamento, porque delírium, privação de sono, infecção, progressão da doença e outras medicações também entram no diferencial.

Adesão e rotina: A adesão pode oscilar quando o paciente percebe benefícios motores, sonolência incômoda, vergonha de efeitos comportamentais ou dificuldade prática de manter rotina de uso em meio a consultas e limitações físicas. No consultório, isso aparece como narrativa inconsistente sobre horários, dias "melhores e piores" sem padrão claro ou mudanças bruscas de funcionamento que não acompanham eventos de vida. Diferenciar irregularidade de uso de progressão da condição de base ajuda a evitar leituras psicodinâmicas excessivas de um problema que pode ser, em parte, organizacional ou ligado à tolerabilidade."

O que observar em sessão

- **Impulsos e controle:** Em parte dos pacientes, podem surgir compras excessivas, aumento de jogo, sexualidade mais impulsiva, busca de recompensa ou decisões pouco usuais para a linha de base. Na sessão, isso às vezes aparece como racionalização, menor crítica sobre consequências ou relato de comportamentos que o paciente descreve como “mais automáticos” do que propriamente desejados. Vale diferenciar de reação a estresse, traços prévios de personalidade, episódio de humor elevado ou alívio legítimo de apatia associada à condição de base.

Sono e sonolência: Sonolência diurna, cochilos involuntários e sensação de rebaixamento de alerta podem interferir no ritmo da sessão, na atenção sustentada e na capacidade de elaboração. Em alguns casos, o paciente parece mais lento ou menos responsivo sem que isso corresponda a piora depressiva. Convém observar se o padrão começou após mudança recente no tratamento, se varia conforme o horário, e se também pode estar sendo influenciado por noites ruins, dor, benzodiazepínicos, outros sedativos ou exaustão pela doença.

Ativação e humor: Alguns pacientes descrevem mais energia, inquietação, redução da necessidade percebida de descanso ou sensação de estar “ligado”, o que pode ser vivido como melhora inicial. Na sessão, a diferença entre ativação medicamentosa, ansiedade, alívio de lentificação motora e uma possível virada de humor depende do grau de aceleração, da expansividade, da autocritica e do impacto funcional. Eventos de vida positivos, retomada de autonomia e flutuações do quadro neurológico também podem confundir essa leitura.

Percepção e realidade: Podem aparecer experiências incomuns, estranheza perceptiva, sensação de presença, sonhos muito vívidos ou interpretações menos ancoradas no habitual, sobretudo em pacientes mais vulneráveis ou com doença neurológica avançada. Na sessão, isso pode surgir de modo hesitante, com vergonha ou medo de parecer “louco”, o que pede escuta concreta e sem confronto. É importante não atribuir automaticamente ao medicamento, porque delírium, privação de sono, infecção, progressão da doença e outras medicações também entram no diferencial.

Adesão e rotina: A adesão pode oscilar quando o paciente percebe benefícios motores, sonolência incômoda, vergonha de efeitos comportamentais ou dificuldade prática de manter rotina de uso em meio a consultas e limitações físicas. No consultório, isso aparece como narrativa inconsistente sobre horários, dias “melhores e piores” sem padrão claro ou mudanças bruscas de funcionamento que não acompanham eventos de vida. Diferenciar irregularidade de uso de progressão da condição de base ajuda a evitar leituras psicodinâmicas excessivas de um problema que pode ser, em parte, organizacional ou ligado à tolerabilidade.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O dicloridrato de pramipexol é um agonista dopaminérgico usado sobretudo na doença de Parkinson e na síndrome das pernas inquietas. No consultório de terapia, costuma aparecer menos pelo nome do fármaco e mais por mudanças em impulso, sono, energia, rotina e relação com o próprio corpo e com a doença de base. Alterações subjetivas podem surgir nas primeiras semanas após início ou mudança recente do tratamento, e oscilações ao longo do dia podem se confundir com progressão do quadro neurológico, privação de sono, dor, outras medicações ou adesão irregular. O ponto central na sessão é discriminar se houve mudança de padrão comportamental, especialmente em controle de impulsos, sonolência e organização da vida cotidiana.

Perguntas úteis

- "Essas mudanças de impulso ou busca de prazer parecem escolhas que fazem sentido para você no momento, ou acontecem como algo que depois você estranha e reconhece como fora do seu padrão? , Quando você fica mais sonolento ou mais lento, isso vem junto de tristeza e desesperança, ou é mais uma queda de alerta e disposição física sem mudança importante no humor? , Essa fase de mais energia trouxe também menos necessidade de sono, fala mais acelerada, gastos ou decisões incomuns para você, ou ficou restrita a uma sensação de estar funcionando melhor? , Essas experiências estranhas acontecem mais quando você está muito cansado, à noite ou em dias de pior sono, ou aparecem mesmo quando o restante do dia está estável? , Nos dias em que você se percebe muito diferente, houve alguma mudança recente na rotina do remédio ou esses dias variam mesmo quando sua rotina está igual?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar comportamentos impulsivos com prejuízo financeiro
- sexual ou relacional
- pode valer alinhar com o médico assistente para avaliar a temporalidade da mudança e o impacto funcional
- Quando a sonolência diurna começa a comprometer segurança
- trabalho
- direção ou autocuidado
- pode valer comunicar o médico assistente pela repercussão prática do quadro
- Quando surgem experiências perceptivas incomuns
- confusão ou maior desorganização do pensamento em relação à linha de base
- pode valer contato com o médico para diferenciar efeito do tratamento de intercorrência clínica ou progressão da condição neurológica
- Quando há aceleração importante
- redução do sono e condutas expansivas fora do padrão
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se há mudança de estado mental associada ao tratamento ou ao quadro de base

Amarelo: alinhar em breve

- Quando a adesão parece irregular por incômodo com efeitos subjetivos ou por dificuldade de rotina
- pode valer comunicar o médico assistente porque isso pode distorcer a leitura clínica da evolução

Vermelho: tratar como urgência

- Surge confusão importante
- desorientação
- fala muito desconexa ou percepção claramente alterada em relação ao funcionamento habitual.: Interromper a exploração interpretativa
- avaliar segurança imediata e acionar hoje o médico assistente
- rede de apoio ou serviço de urgência conforme gravidade
- Aparecem impulsos com risco agudo
- como gastos graves
- exposição sexual perigosa ou comportamento sem crítica suficiente para se proteger.: Priorizar contenção de risco
- envolver rede de apoio quando necessário e buscar contato médico no mesmo dia
- O paciente apresenta aceleração acentuada
- quase não dorme
- fala sem pausa e toma decisões grandiosas ou muito fora da realidade habitual.: Tratar como mudança aguda do estado mental
- avaliar risco e articular contato médico no mesmo dia
- com urgência se houver perda de juízo crítico

Frase clínica

O foco clínico é notar mudanças de impulso, sono e realidade vivida que possam se confundir com evolução neurológica ou adesão irregular.

055 DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOIDRATADO

Substância: Dicloridrato de Pramipexol Monoidratado.

Nomes Comerciais: Quera, Stabil Xr, Dicloridrato de Pramipexol

Uso comum

- Pramipexol é um agonista dopaminérgico usado sobretudo na doença de Parkinson e, em alguns contextos, na síndrome das pernas inquietas. No consultório de terapia, costuma aparecer mais pelo impacto subjetivo do tratamento e da condição de base do que por um efeito psíquico isolado. Mudanças podem surgir nas primeiras semanas após início ou ajuste, e também ao longo do uso contínuo, com oscilação entre períodos de maior lentificação, sonolência, impulsividade ou alteração do ritmo de sono. O ponto central na sessão é distinguir o que acompanha a evolução neurológica e a rotina do tratamento do que parece mudança recente de comportamento, adesão irregular ou efeito que o paciente tende a minimizar por vergonha ou pouca crítica.

O paciente pode relatar

- **"Impulsividade:** Em parte dos pacientes, podem surgir compras excessivas, aumento de jogo, busca sexual incomum para a linha de base ou outras condutas mais desinibidas, às vezes descritas como "vontades" difíceis de frear. Na sessão, isso pode aparecer como racionalização, redução da autocrítica ou surpresa da família com mudanças de padrão. Vale não ler automaticamente como traço de personalidade, hipomania primária ou simples reação ao estresse financeiro ou conjugal, sobretudo quando a mudança é relativamente nova e pouco ego-distônica.

Sonolência: Sonolência diurna, queda de alerta e sensação de "apagão" ou cochilos involuntários podem interferir no andamento da sessão e na funcionalidade cotidiana. O terapeuta pode notar lentificação, oscilação de atenção e dificuldade de sustentar elaboração mais complexa, o que também pode ser confundido com depressão, fadiga da doença neurológica, privação de sono ou uso concomitante de outros fármacos sedativos. A discriminação depende de comparar com a baseline e mapear em que momentos do dia isso se intensifica.

Humor e motivação: Alguns pacientes descrevem oscilação entre maior disposição e iniciativa e, em outros momentos, apatia, irritabilidade ou desânimo. Na sessão, isso pode confundir a leitura da evolução do quadro de base: melhora motora pode ampliar engajamento sem que haja melhora afetiva equivalente, enquanto frustração com perdas funcionais pode parecer depressão medicamentosa. Também entram como confundidores eventos de vida, dor crônica, sono ruim e a própria experiência de viver com doença progressiva.

Sono e ritmo: Alterações do sono podem aparecer como fragmentação, inversão de horários, sonhos vívidos ou sonolência em horários pouco usuais. Em terapia, isso repercute como menor tolerância à frustração, pior atenção e sensação de estranhamento do próprio corpo e do próprio ritmo. Nem sempre é simples separar o que decorre do medicamento, do avanço da condição neurológica, da ansiedade antecipatória ou de hábitos de sono já desorganizados.

Adesão e vergonha: A adesão pode ficar irregular quando o paciente minimiza efeitos incômodos, sente vergonha de mudanças de comportamento ou teme perder ganhos funcionais. Isso às vezes aparece indiretamente: faltas, relato confuso sobre rotina, contradições entre o que o paciente diz e o que familiares observam, ou súbita piora sem explicação clara. Nesses casos, vale considerar tanto uso irregular quanto dificuldade de nomear experiências que o paciente percebe como moralmente embaraçosas."

O que observar em sessão

- **Impulsividade:** Em parte dos pacientes, podem surgir compras excessivas, aumento de jogo, busca sexual incomum para a linha de base ou outras condutas mais desinibidas, às vezes descritas como “vontades” difíceis de frear. Na sessão, isso pode aparecer como racionalização, redução da autocrítica ou surpresa da família com mudanças de padrão. Vale não ler automaticamente como traço de personalidade, hipomania primária ou simples reação ao estresse financeiro ou conjugal, sobretudo quando a mudança é relativamente nova e pouco ego-distônica.

Sonolência: Sonolência diurna, queda de alerta e sensação de “apagão” ou cochilos involuntários podem interferir no andamento da sessão e na funcionalidade cotidiana. O terapeuta pode notar lentificação, oscilação de atenção e dificuldade de sustentar elaboração mais complexa, o que também pode ser confundido com depressão, fadiga da doença neurológica, privação de sono ou uso concomitante de outros fármacos sedativos. A discriminação depende de comparar com a baseline e mapear em que momentos do dia isso se intensifica.

Humor e motivação: Alguns pacientes descrevem oscilação entre maior disposição e iniciativa e, em outros momentos, apatia, irritabilidade ou desânimo. Na sessão, isso pode confundir a leitura da evolução do quadro de base: melhora motora pode ampliar engajamento sem que haja melhora afetiva equivalente, enquanto frustração com perdas funcionais pode parecer depressão medicamentosa. Também entram como confundidores eventos de vida, dor crônica, sono ruim e a própria experiência de viver com doença progressiva.

Sono e ritmo: Alterações do sono podem aparecer como fragmentação, inversão de horários, sonhos vívidos ou sonolência em horários pouco usuais. Em terapia, isso repercute como menor tolerância à frustração, pior atenção e sensação de estranhamento do próprio corpo e do próprio ritmo. Nem sempre é simples separar o que decorre do medicamento, do avanço da condição neurológica, da ansiedade antecipatória ou de hábitos de sono já desorganizados.

Adesão e vergonha: A adesão pode ficar irregular quando o paciente minimiza efeitos incômodos, sente vergonha de mudanças de comportamento ou teme perder ganhos funcionais. Isso às vezes aparece indiretamente: faltas, relato confuso sobre rotina, contradições entre o que o paciente diz e o que familiares observam, ou súbita piora sem explicação clara. Nesses casos, vale considerar tanto uso irregular quanto dificuldade de nomear experiências que o paciente percebe como moralmente embaraçosas.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Pramipexol é um agonista dopaminérgico usado sobretudo na doença de Parkinson e, em alguns contextos, na síndrome das pernas inquietas. No consultório de terapia, costuma aparecer mais pelo impacto subjetivo do tratamento e da condição de base do que por um efeito psíquico isolado. Mudanças podem surgir nas primeiras semanas após início ou ajuste, e também ao longo do uso contínuo, com oscilação entre períodos de maior lentificação, sonolência, impulsividade ou alteração do ritmo de sono. O ponto central na sessão é distinguir o que acompanha a evolução neurológica e a rotina do tratamento do que parece mudança recente de comportamento, adesão irregular ou efeito que o paciente tende a minimizar por vergonha ou pouca crítica.

Perguntas úteis

- "Essas mudanças de impulso ou de vontade parecem vir como algo novo para você, ou soam como uma intensificação de um traço que já existia antes? , Quando o sono ou a sonolência atrapalham, isso acontece de modo mais espalhado ao longo da semana ou em momentos mais previsíveis do dia? , Quando você se percebe mais animado ou mais ativo, isso vem junto de maior clareza e organização, ou com pressa, menor freio e decisões das quais depois você estranha? , O desânimo que aparece tem mais cara de tristeza e desesperança, ou de cansaço, lentidão e dificuldade de se manter desperto? , Você tem evitado contar alguma mudança de comportamento por vergonha, medo de julgamento ou receio do que isso possa significar?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando surgem compras fora do padrão
- jogo
- aumento importante de busca sexual ou outras condutas impulsivas novas
- pode valer alinhar com o médico assistente para avaliar a relação temporal com o tratamento e o impacto funcional
- Quando a sonolência diurna passa a comprometer segurança
- trabalho
- direção ou a própria possibilidade de o paciente se manter acordado em atividades usuais
- pode valer comunicação em curto prazo pela repercussão prática
- Quando há piora importante do sono
- do ritmo diário ou da atenção sem explicação suficiente por eventos de vida
- pode ser útil alinhar com o médico para discriminar efeito do tratamento
- progressão do quadro neurológico ou uso irregular
- Quando o paciente admite adesão irregular
- interrupções por conta própria ou omissão de efeitos por vergonha
- pode valer contato com o médico assistente porque isso dificulta a leitura clínica da evolução
- Quando aparece mudança nítida de humor ou comportamento com redução de crítica
- maior aceleração e decisões incomuns para a linha de base

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicação para avaliação médica mais próxima

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente relata episódios de adormecer de forma súbita em situações de risco
- como dirigindo
- trabalhando com máquinas ou atravessando a rua.: Interromper o foco interpretativo
- priorizar segurança imediata e acionar no mesmo dia o médico assistente e rede de apoio; considerar emergência se não houver contenção segura
- Surge mudança abrupta de comportamento com forte desinibição
- aceleração
- redução importante do sono e decisões potencialmente danosas
- fora da linha de base.: Tratar como situação de urgência clínica
- avaliar risco imediato e acionar no mesmo dia o médico assistente e a rede de apoio

Frase clínica

O foco clínico é rastrear impulsividade, sonolência e mudanças de ritmo que podem passar despercebidas ou ser atribuídas apenas à doença de base.

056 MESILATO DE SAFINAMIDA

Substância: Mesilato de Safinamida.

Nomes Comerciais: Xadago

Uso comum

- Safinamida é um adjuvante usado na doença de Parkinson, geralmente quando o paciente já convive com flutuações motoras e rotina medicamentosa complexa. No consultório, o foco costuma ser menos um “efeito psiquiátrico típico” e mais como mudanças ao longo das primeiras semanas e nos meses seguintes repercutem em energia, sono, irritabilidade, impulsividade, percepção de autonomia e previsibilidade do dia. Vale acompanhar se houve mudança recente no padrão de funcionamento, se o paciente associa isso a horários e oscilações do dia, e se a leitura clínica pode estar sendo confundida pela progressão da doença, por outras medicações antiparkinsonianas ou por adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Oscilação diária:** O paciente pode descrever períodos do dia em que se sente mais solto, mais travado, mais confiante ou mais frustrado, e essa alternância às vezes aparece na sessão como variação de ritmo, expressividade e tolerância à espera. Nem toda oscilação emocional indica mudança de humor primária; em Parkinson, a experiência subjetiva costuma acompanhar o quanto o corpo responde ao tratamento ao longo do dia. Vale observar se a instabilidade segue um padrão temporal relativamente previsível ou se coincide mais com eventos de vida, conflitos e estressores recentes.

Sono e ativação: Alguns pacientes passam a relatar sono mais fragmentado, dificuldade para desacelerar à noite ou sensação de estar mais "ligados", enquanto outros chegam mais cansados por noites ruins e rotina corporal exigente. Na sessão, isso pode se parecer com ansiedade basal, aceleração associativa ou irritabilidade inespecífica. A discriminação clínica melhora quando se investiga se a mudança surgiu junto de alteração recente no tratamento, se varia conforme o horário do dia e se difere do padrão anterior do paciente.

Impulsividade: Em parte dos casos, podem surgir compras menos pensadas, aumento de busca por prazer imediato, maior desinibição ou decisões mais rápidas do que o habitual, algo que às vezes aparece primeiro como mudança de tom narrativo e menor freio reflexivo. Isso pode ser confundido com alívio legítimo após melhora funcional, reação a perdas de autonomia ou traços prévios de personalidade. O ponto central é comparar com a linha de base e verificar se houve custo concreto, arrependimento posterior ou estranhamento por parte do próprio paciente e da família.

Humor e irritabilidade: Melhora motora pode vir acompanhada de alívio emocional, mas também podem aparecer irritabilidade, impaciência ou labilidade que o paciente não reconhece de imediato como mudança relevante. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como conflito relacional, depressão reativa ou simples cansaço de doença crônica. Ajuda observar se a reatividade aumentou junto com outras mudanças de sono, energia e impulsividade, ou se está mais claramente ligada a frustrações concretas e ao curso da doença.

Carga do tratamento: Como costuma entrar em esquemas já complexos, a safinamida frequentemente aparece no consultório através da experiência de viver sob horários, dependência de resposta corporal e medo de perder funcionalidade. O paciente pode oscilar entre esperança, hipervigilância a sinais do corpo e desânimo quando o dia não rende como esperado. Adesão irregular, confusão com múltiplos remédios e dificuldade de nomear o que mudou por qual motivo podem embaralhar a leitura clínica mais do que um efeito isolado da substância."

O que observar em sessão

- **Oscilação diária:** O paciente pode descrever períodos do dia em que se sente mais solto, mais travado, mais confiante ou mais frustrado, e essa alternância às vezes aparece na sessão como variação de ritmo, expressividade e tolerância à espera. Nem toda oscilação emocional indica mudança de humor primária; em Parkinson, a experiência subjetiva costuma acompanhar o quanto o corpo responde ao tratamento ao longo do dia. Vale observar se a instabilidade segue um padrão temporal relativamente previsível ou se coincide mais com eventos de vida, conflitos e estressores recentes.

Sono e ativação: Alguns pacientes passam a relatar sono mais fragmentado, dificuldade para desacelerar à noite ou sensação de estar mais “ligados”, enquanto outros chegam mais cansados por noites ruins e rotina corporal exigente. Na sessão, isso pode se parecer com ansiedade basal, aceleração associativa ou irritabilidade inespecífica. A discriminação clínica melhora quando se investiga se a mudança surgiu junto de alteração recente no tratamento, se varia conforme o horário do dia e se difere do padrão anterior do paciente.

Impulsividade: Em parte dos casos, podem surgir compras menos pensadas, aumento de busca por prazer imediato, maior desinibição ou decisões mais rápidas do que o habitual, algo que às vezes aparece primeiro como mudança de tom narrativo e menor freio reflexivo. Isso pode ser confundido com alívio legítimo após melhora funcional, reação a perdas de autonomia ou traços prévios de personalidade. O ponto central é comparar com a linha de base e verificar se houve custo concreto, arrependimento posterior ou estranhamento por parte do próprio paciente e da família.

Humor e irritabilidade: Melhora motora pode vir acompanhada de alívio emocional, mas também podem aparecer irritabilidade, impaciência ou labilidade que o paciente não reconhece de imediato como mudança relevante. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como conflito relacional, depressão reativa ou simples cansaço de doença crônica. Ajuda observar se a reatividade aumentou junto com outras mudanças de sono, energia e impulsividade, ou se está mais claramente ligada a frustrações concretas e ao curso da doença.

Carga do tratamento: Como costuma entrar em esquemas já complexos, a safinamida frequentemente aparece no consultório através da experiência de viver sob horários, dependência de resposta corporal e medo de perder funcionalidade. O paciente pode oscilar entre esperança, hipervigilância a sinais do corpo e desânimo quando o dia não rende como esperado. Adesão irregular, confusão com múltiplos remédios e dificuldade de nomear o que mudou por qual motivo podem embaralhar a leitura clínica mais do que um efeito isolado da substância.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Safinamida é um adjuvante usado na doença de Parkinson, geralmente quando o paciente já convive com flutuações motoras e rotina medicamentosa complexa. No consultório, o foco costuma ser menos um “efeito psiquiátrico típico” e mais como mudanças ao longo das primeiras semanas e nos meses seguintes repercutem em energia, sono, irritabilidade, impulsividade, percepção de autonomia e previsibilidade do dia. Vale acompanhar se houve mudança recente no padrão de funcionamento, se o paciente associa isso a horários e oscilações do dia, e se a leitura clínica pode estar sendo confundida pela progressão da doença, por outras medicações antiparkinsonianas ou por adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que ficou mais acelerado ou inquieto, isso aparece como preocupação na cabeça ou como uma sensação de estar mais “ligado” no corpo e nas ações? , Essas mudanças de humor ou irritação acontecem em qualquer contexto ou você percebe que elas acompanham horários do dia em que seu corpo responde melhor ou pior? , O aumento de disposição veio com mais clareza e autonomia ou junto com atitudes que depois pareceram impulsivas, excessivas ou pouco parecidas com você? , Seu sono piorou por pensamentos e preocupações, ou por uma sensação de que o corpo e a mente não desaceleram mesmo quando você quer descansar? , Quando você se sente diferente, isso costuma durar dias de forma contínua ou oscila dentro do mesmo dia, em blocos mais curtos? , Desde que essa medicação entrou na rotina, houve dias em que você pulou, confundiu ou mudou horários e depois percebeu diferença no seu funcionamento?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar impulsividade
- desinibição ou busca de prazer com prejuízo financeiro
- sexual ou relacional
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a mudança no contexto do tratamento em curso
- Quando surgem piora importante do sono
- ativação persistente ou irritabilidade nova nas semanas após introdução ou mudança recente do esquema
- pode valer comunicar para ajudar na discriminação entre efeito do tratamento e evolução clínica
- Quando a sessão mostra oscilação marcada ao longo do dia
- com impacto funcional e sofrimento
- pode valer contato com o médico para registrar o padrão temporal percebido pelo paciente
- Quando o paciente admite adesão irregular
- confusão entre medicações ou abandono silencioso por incômodo subjetivo
- pode valer alinhar com o médico assistente porque a leitura da resposta clínica fica comprometida

Amarelo: alinhar em breve

- Quando aparece rebaixamento importante do humor
- desesperança ou ideação suicida em meio a mudança recente do tratamento ou piora da funcionalidade
- pode valer comunicação no mesmo período para avaliação médica oportuna

Vermelho: tratar como urgência

- Ideação suicida atual
- desesperança intensa ou fala de que não vê saída
- especialmente se isso surgiu junto de piora recente do funcionamento ou mudança no tratamento.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário
- Agitação importante
- confusão aguda
- desorganização incomum ou rebaixamento súbito da capacidade de se orientar na sessão.: Interromper a condução habitual da sessão e buscar avaliação médica imediata
- com apoio de familiar ou serviço de urgência conforme o contexto

Frase clínica

O foco é distinguir oscilação do Parkinson e da rotina medicamentosa de mudanças emocionais primárias ou adesão irregular.

057 ROTIGOTINA

Substância: Rotigotina.

Nomes Comerciais: Neupro

Uso comum

- Rotigotina é um agonista dopaminérgico em adesivo transdérmico, mais encontrado em pacientes com doença de Parkinson e, em alguns casos, síndrome das pernas inquietas. No consultório, costuma importar menos a farmacologia e mais como mudanças de impulso, sono, energia e ritmo psicomotor atravessam a vida psíquica e a sessão. Nas primeiras semanas após início ou mudança recente do tratamento, vale observar com mais atenção surgimento de sonolência, náusea, inquietação, maior impulsividade ou alteração do padrão de sono; ao longo dos meses, o foco passa a ser oscilação funcional, adesão ao adesivo e impacto subjetivo de viver com uma condição neurológica crônica.

O paciente pode relatar

- **"Sono e vigília:** Pode aparecer sonolência diurna, cochilos involuntários, sensação de estar mais lento em certos horários ou, em outra direção, noites mais fragmentadas e cansaço no dia seguinte. Na sessão, isso pode se confundir com apatia depressiva, exaustão por sobrecarga de cuidados ou piora da própria condição neurológica. Vale notar se a oscilação tem relação temporal com momentos do dia, com a rotina do adesivo ou com noites mal dormidas, em vez de assumir de saída uma mudança primária de humor.

Impulsividade: Em parte dos pacientes, surgem compras excessivas, aumento de jogo, busca sexual incomum, maior urgência por recompensas ou decisões menos filtradas, às vezes vividas com vergonha e ocultadas do terapeuta e da família. Isso pode ser lido apressadamente como traço de personalidade, reação a estresse ou fase de aparente melhora do humor. O dado clínico mais útil costuma ser a quebra de baseline: comportamentos novos, mais automáticos e pouco compatíveis com a história prévia merecem registro cuidadoso.

Humor e ativação: Alguns pacientes chegam mais animados, falantes, confiantes ou com sensação de retomada, enquanto outros oscilam entre frustração, irritabilidade e desânimo ligados à limitação física e à progressão da doença. Na sessão, o desafio é diferenciar bem-estar legítimo por melhora funcional de uma ativação menos integrada, com redução de freios e autocritica. A observação do encadeamento do pensamento, do sono recente, do grau de planejamento realista e da consonância com o funcionamento habitual ajuda nessa leitura.

Náusea e tolerabilidade: No início do uso ou após mudanças recentes, mal-estar, tontura, náusea e desconforto corporal podem reduzir presença psíquica, paciência e disponibilidade para elaboração. O paciente pode parecer mais irritadiço, disperso ou pouco acessível afetivamente, e isso às vezes é tomado como resistência ou retraimento defensivo. Quando esses sinais surgem junto de uma mudança recente no tratamento ou de adesão irregular, convém manter hipótese aberta antes de atribuir o padrão apenas ao processo psicoterápico.

Adesão e rotina: Por ser um adesivo, o uso cotidiano depende de uma rotina concreta, memória, organização e aceitação do tratamento, o que pode falhar silenciosamente. Esquecimentos, uso irregular, incômodo com a pele, constrangimento corporal ou ambivalência diante da condição de base podem produzir oscilações que parecem instabilidade emocional ou piora inexplicada. Na sessão, costuma ser mais útil explorar como o tratamento entrou na vida diária do que perguntar apenas se o paciente 'está tomando direito'.

Identidade e funcionalidade: Em pacientes com Parkinson, a medicação aparece dentro de uma experiência mais ampla de perda de espontaneidade, dependência crescente, vergonha do corpo e renegociação de papéis familiares e profissionais. Melhoras motoras parciais podem conviver com luto pela autonomia, e pioras subjetivas podem refletir mais a condição de base do que o tratamento em si. O trabalho clínico frequentemente gira em torno de sustentar agência e continuidade de si sem reduzir a sessão a monitoramento de sintomas."

O que observar em sessão

- **Sono e vigília:** Pode aparecer sonolência diurna, cochilos involuntários, sensação de estar mais lento em certos horários ou, em outra direção, noites mais fragmentadas e cansaço no dia seguinte. Na sessão, isso pode se confundir com apatia depressiva, exaustão por sobrecarga de cuidados ou piora da própria condição neurológica. Vale notar se a oscilação tem relação temporal com momentos do dia, com a rotina do adesivo ou com noites mal dormidas, em vez de assumir de saída uma mudança primária de humor.

Impulsividade: Em parte dos pacientes, surgem compras excessivas, aumento de jogo, busca sexual incomum, maior urgência por recompensas ou decisões menos filtradas, às vezes vividas com vergonha e ocultadas do terapeuta e da família. Isso pode ser lido apressadamente como traço de personalidade, reação a estresse ou fase de aparente melhora do humor. O dado clínico mais útil costuma ser a quebra de baseline: comportamentos novos, mais automáticos e pouco compatíveis com a história prévia merecem registro cuidadoso.

Humor e ativação: Alguns pacientes chegam mais animados, falantes, confiantes ou com sensação de retomada, enquanto outros oscilam entre frustração, irritabilidade e desânimo ligados à limitação física e à progressão da doença. Na sessão, o desafio é diferenciar bem-estar legítimo por melhora funcional de uma ativação menos integrada, com redução de freios e autocritica. A observação do encadeamento do pensamento, do sono recente, do grau de planejamento realista e da consonância com o funcionamento habitual ajuda nessa leitura.

Náusea e tolerabilidade: No início do uso ou após mudanças recentes, mal-estar, tontura, náusea e desconforto corporal podem reduzir presença psíquica, paciência e disponibilidade para elaboração. O paciente pode parecer mais irritadiço, disperso ou pouco acessível afetivamente, e isso às vezes é tomado como resistência ou retraimento defensivo. Quando esses sinais surgem junto de uma mudança recente no tratamento ou de adesão irregular, convém manter hipótese aberta antes de atribuir o padrão apenas ao processo psicoterápico.

Adesão e rotina: Por ser um adesivo, o uso cotidiano depende de uma rotina concreta, memória, organização e aceitação do tratamento, o que pode falhar silenciosamente. Esquecimentos, uso irregular, incômodo com a pele, constrangimento corporal ou ambivalência diante da condição de base podem produzir oscilações que parecem instabilidade emocional ou piora inexplicada. Na sessão, costuma ser mais útil explorar como o tratamento entrou na vida diária do que perguntar apenas se o paciente 'está tomando direito'.

Identidade e funcionalidade: Em pacientes com Parkinson, a medicação aparece dentro de uma experiência mais ampla de perda de espontaneidade, dependência crescente, vergonha do corpo e renegociação de papéis familiares e profissionais. Melhoras motoras parciais podem conviver com luto pela autonomia, e pioras subjetivas podem refletir mais a condição de base do que o tratamento em si. O trabalho clínico frequentemente gira em torno de sustentar agência e continuidade de si sem reduzir a sessão a monitoramento de sintomas.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Rotigotina é um agonista dopaminérgico em adesivo transdérmico, mais encontrado em pacientes com doença de Parkinson e, em alguns casos, síndrome das pernas inquietas. No consultório, costuma importar menos a farmacologia e mais como mudanças de impulso, sono, energia e ritmo psicomotor atravessam a vida psíquica e a sessão. Nas primeiras semanas após início ou mudança recente do tratamento, vale observar com mais atenção surgimento de sonolência, náusea, inquietação, maior impulsividade ou alteração do padrão de sono; ao longo dos meses, o foco passa a ser oscilação funcional, adesão ao adesivo e impacto subjetivo de viver com uma condição neurológica crônica.

Perguntas úteis

- "Quando você se percebe mais acelerado ou mais disposto, isso vem junto de maior clareza e organização ou junto de decisões mais impulsivas e sono reduzido? , Esses comportamentos que parecem fora do seu padrão, como gastar mais, buscar mais estímulo ou agir sem pensar, começaram depois de alguma mudança recente na sua rotina de tratamento ou já apareciam antes em outros momentos da vida? , Quando o cansaço aparece, ele se parece mais com sono que toma o corpo, com cochilos e lentidão, ou com desânimo e falta de interesse pelas coisas? , Nos dias em que você fica mais irritado ou disperso, isso costuma vir acompanhado de mal-estar físico, tontura ou enjoo, ou acontece mesmo quando o corpo está estável? , Como o uso do adesivo entrou na sua rotina real: há esquecimentos, incômodo com a pele, vergonha de usar ou momentos em que você evita colocar sem comentar com ninguém?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar comportamentos impulsivos novos ou claramente intensificados
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a mudança no contexto do tratamento e do risco psicossocial
- Quando sonolência diurna
- cochilos involuntários ou queda importante de atenção começam a interferir na segurança
- no trabalho ou na condução da rotina
- pode valer comunicação em dias para avaliação clínica
- Quando há oscilação importante entre melhora aparente e piora funcional sem explicação clara
- sobretudo com suspeita de uso irregular do adesivo
- pode ser útil alinhar com o médico para qualificar a leitura do quadro
- Quando o paciente descreve náusea
- tontura ou mal-estar persistentes a ponto de comprometer adesão ou presença nas sessões
- pode valer contato para evitar abandono silencioso do tratamento
- Quando surgem sinais de ativação pouco compatíveis com o baseline
- com redução de sono
- aumento de impulsividade e autocrítica diminuída

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicação breve para avaliação de possível mudança de estado

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente chega muito acelerado
- dormindo pouco
- com fala pressionada
- grandiosidade ou decisões arriscadas claramente fora do seu funcionamento usual.: Tratar como mudança aguda de estado
- acionar o médico assistente no mesmo dia e mobilizar rede de apoio e avaliação de urgência se houver risco comportamental
- Ideias de morte
- autoagressão ou perda importante de juízo crítico aparecem junto de impulsividade
- desorganização ou sofrimento intenso.: Fazer manejo de risco imediatamente
- acionar rede de apoio e avaliação de urgência quando necessário
- além de comunicar o médico assistente no mesmo dia

Frase clínica

O foco clínico é distinguir melhora funcional de ativação desorganizada, impulsividade e sonolência que alteram o baseline do paciente.

058 AMISSULPRIDA

Substância: Amissulprida.

Nomes Comerciais: Socian

Uso comum

- A amissulprida é um antipsicótico usado sobretudo em quadros psicóticos e, em alguns contextos, em apresentações com retraimento, embotamento ou desorganização. No consultório, o ponto central costuma ser distinguir melhora da desorganização e da agitação de um lado, e sedação, lentificação, apatia ou inquietação corporal de outro. Mudanças mais perceptíveis podem surgir nos primeiros dias a 2 semanas, enquanto a consolidação da resposta tende a ficar mais clara ao longo de 4 a 6 semanas. Também vale acompanhar adesão irregular, já que interrupções ou uso intermitente podem reaparecer na sessão como piora inespecífica, estranhamento corporal ou retorno de sintomas antes atribuídos apenas ao quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter fala mais lenta, menor espontaneidade, sonolência ou dificuldade de sustentar o fio associativo, especialmente no início do uso ou após mudanças recentes na rotina medicamentosa. Isso pode ser confundido com piora depressiva, exaustão por insônia prévia ou retraimento próprio do quadro psicótico. Vale observar se a lentificação veio junto de redução de angústia e desorganização, ou se apareceu como empobrecimento novo do contato e da iniciativa.

Inquietação corporal: Pode surgir uma inquietação difícil de nomear, com necessidade de mudar de posição, balançar pernas, levantar-se com frequência ou relatar desconforto interno sem conteúdo ansioso claro. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, tensão por tema sensível ou agitação do próprio transtorno, mas o padrão corporal contínuo e pouco ligado ao conteúdo da fala ajuda a diferenciar. Quando o paciente descreve alívio apenas ao se mover, convém registrar com precisão porque esse tipo de desconforto pode comprometer adesão silenciosamente.

Acesso afetivo: À medida que a desorganização ou a intensidade psicótica diminuem, alguns pacientes ficam mais acessíveis ao vínculo e à elaboração; outros parecem mais planos, com menor modulação emocional e menos ressonância afetiva. A dificuldade é não tomar embotamento como melhora apenas porque há menos conflito na sessão, nem interpretar toda redução de intensidade como efeito indesejado. Comparar com a baseline do paciente e com a qualidade do contato, e não só com o volume do sofrimento, costuma ser mais útil.

Prolactina e sexualidade: Alterações em libido, função sexual, sensibilidade corporal e, às vezes, mudanças menstruais ou secreção mamária podem aparecer no relato, muitas vezes com vergonha e tendência a omitir. No setting, isso pode se manifestar indiretamente como afastamento de intimidade, queda de autoestima, irritabilidade no vínculo ou abandono silencioso do tratamento. Também aqui entram fatores concorrentes importantes, como sintomas negativos, depressão, conflitos relacionais e outras medicações em uso.

Adesão e continuidade: A amissulprida pode ficar associada, para o paciente, tanto a alívio de experiências muito perturbadoras quanto a sensação de estranhamento corporal ou perda de vivacidade, o que favorece uso irregular sem comunicação espontânea. Na sessão, oscilações de presença psíquica, retorno de desconfiança, piora do sono ou reaparecimento de inquietação podem refletir evolução do quadro, estressores recentes ou interrupções parciais. Perguntar pelo padrão concreto de uso, sem tom fiscalizatório, ajuda mais do que perguntar genericamente se a pessoa 'está tomando direito'.

Sinais físicos visíveis: Alguns efeitos aparecem primeiro como observação clínica simples: rigidez, expressão facial menos móvel, tremor fino, marcha mais travada ou salivação aumentada. Esses sinais podem ser lidos apressadamente como ansiedade, envelhecimento, retraimento defensivo ou traço de personalidade, sobretudo quando o paciente não os nomeia. Quando surgem de modo novo ou se intensificam, vale descrevê-los de forma concreta no registro e considerar comunicação com o médico assistente."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter fala mais lenta, menor espontaneidade, sonolência ou dificuldade de sustentar o fio associativo, especialmente no início do uso ou após mudanças recentes na rotina medicamentosa. Isso pode ser confundido com piora depressiva, exaustão por insônia prévia ou retraimento próprio do quadro psicótico. Vale observar se a lentificação veio junto de redução de angústia e desorganização, ou se apareceu como empobrecimento novo do contato e da iniciativa.

Inquietação corporal: Pode surgir uma inquietação difícil de nomear, com necessidade de mudar de posição, balançar pernas, levantar-se com frequência ou relatar desconforto interno sem conteúdo ansioso claro. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, tensão por tema sensível ou agitação do próprio transtorno, mas o padrão corporal contínuo e pouco ligado ao conteúdo da fala ajuda a diferenciar. Quando o paciente descreve alívio apenas ao se mover, convém registrar com precisão porque esse tipo de desconforto pode comprometer adesão silenciosamente.

Acesso afetivo: À medida que a desorganização ou a intensidade psicótica diminuem, alguns pacientes ficam mais acessíveis ao vínculo e à elaboração; outros parecem mais planos, com menor modulação emocional e menos ressonância afetiva. A dificuldade é não tomar embotamento como melhora apenas porque há menos conflito na sessão, nem interpretar toda redução de intensidade como efeito indesejado. Comparar com a baseline do paciente e com a qualidade do contato, e não só com o volume do sofrimento, costuma ser mais útil.

Prolactina e sexualidade: Alterações em libido, função sexual, sensibilidade corporal e, às vezes, mudanças menstruais ou secreção mamária podem aparecer no relato, muitas vezes com vergonha e tendência a omitir. No setting, isso pode se manifestar indiretamente como afastamento de intimidade, queda de autoestima, irritabilidade no vínculo ou abandono silencioso do tratamento. Também aqui entram fatores concorrentes importantes, como sintomas negativos, depressão, conflitos relacionais e outras medicações em uso.

Adesão e continuidade: A amissulprida pode ficar associada, para o paciente, tanto a alívio de experiências muito perturbadoras quanto a sensação de estranhamento corporal ou perda de vivacidade, o que favorece uso irregular sem comunicação espontânea. Na sessão, oscilações de presença psíquica, retorno de desconfiança, piora do sono ou reaparecimento de inquietação podem refletir evolução do quadro, estressores recentes ou interrupções parciais. Perguntar pelo padrão concreto de uso, sem tom fiscalizatório, ajuda mais do que perguntar genericamente se a pessoa 'está tomando direito'.

Sinais físicos visíveis: Alguns efeitos aparecem primeiro como observação clínica simples: rigidez, expressão facial menos móvel, tremor fino, marcha mais travada ou salivação aumentada. Esses sinais podem ser lidos apressadamente como ansiedade, envelhecimento, retraimento defensivo ou traço de personalidade, sobretudo quando o paciente não os nomeia. Quando surgem de modo novo ou se intensificam, vale descrevê-los de forma concreta no registro e considerar comunicação com o médico assistente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A amisulprida é um antipsicótico usado sobretudo em quadros psicóticos e, em alguns contextos, em apresentações com retraimento, embotamento ou desorganização. No consultório, o ponto central costuma ser distinguir melhora da desorganização e da agitação de um lado, e sedação, lentificação, apatia ou inquietação corporal de outro. Mudanças mais perceptíveis podem surgir nos primeiros dias a 2 semanas, enquanto a consolidação da resposta tende a ficar mais clara ao longo de 4 a 6 semanas. Também vale acompanhar adesão irregular, já que interrupções ou uso intermitente podem reaparecer na sessão como piora inespecífica, estranhamento corporal ou retorno de sintomas antes atribuídos apenas ao quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais travado ou mais lento, isso vem junto de sono e peso no corpo, ou parece mais uma falta de vontade e interesse pelas coisas? , Essa inquietação que aparece no corpo se parece com a sua ansiedade de costume, ligada a pensamentos e situações, ou é mais um incômodo físico que melhora quando você se mexe? , Você sente que está sofrendo menos porque as ideias ficaram mais organizadas, ou porque está com menos acesso às emoções, como se tudo ficasse mais distante? , As mudanças na sua vida sexual ou no interesse por intimidade começaram junto com mudanças no humor e na relação, ou apareceram mesmo quando esses aspectos estavam parecidos com antes? , Quando houve piora nos últimos dias, ela veio depois de algum estresse claro da semana ou coincidiu com dias em que o uso saiu do padrão habitual? , Você percebe esses momentos de estranhamento corporal ou rigidez ao longo do dia inteiro, ou eles aparecem em horários e contextos mais específicos?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- reduzir ou interromper o uso por conta própria por se sentir travado
- inquieto ou sexualmente afetado
- pode valer alinhar com o psiquiatra para prevenir abandono silencioso do tratamento
- Quando surgem rigidez
- tremor
- marcha mais travada
- salivação aumentada ou expressão facial nitidamente menos móvel
- pode valer comunicar o médico assistente para qualificar se há efeito medicamentoso relevante interferindo no funcionamento
- Quando a sessão mostra embotamento novo
- apatia importante ou lentificação que empobrece o vínculo e a elaboração
- pode valer contato com o psiquiatra para diferenciar efeito do tratamento de evolução do quadro
- Quando aparece inquietação corporal persistente
- pouco ligada ao conteúdo emocional e com impacto na permanência em sessão

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico assistente porque esse desconforto costuma comprometer adesão
- Quando não se observa melhora minimamente consistente após 4 a 6 semanas
- ou há retorno de desorganização e desconfiança apesar de relato de uso regular
- pode valer comunicação para reavaliar o momento clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Rebaixamento acentuado do nível de consciência
- confusão importante
- rigidez intensa
- febre referida ou mal-estar físico importante aparecendo junto na sessão ou imediatamente antes dela.: Tratar como urgência clínica: acionar avaliação médica no mesmo dia e
- se necessário
- rede de apoio e serviço de emergência
- Retorno rápido de desorganização grave
- intensa desconfiança
- comando alucinatório ou risco de autoagressão/heteroagressão em contexto de possível interrupção do uso.: Fazer manejo de crise
- acionar psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhar para avaliação de urgência quando houver risco atual

Frase clínica

O foco é separar redução da psicose de sedação, embotamento e inquietação corporal que podem minar vínculo, funcionamento e adesão.

059 ARIPIPAZOL

Substância: Aripiprazol.

Nomes Comerciais: Aripiprazol, Arpejo, Sensaz, Biquiz, Hedd, Toarip, Aquarela, Optary, Aristab Odt, Aristab, Arpio, Harip, Harip Odt, Kavium, Kavium Odt, Aipri

Uso comum

- Aripiprazol é um antipsicótico usado em quadros como transtorno bipolar, esquizofrenia, irritabilidade associada ao autismo e, em alguns casos, como adjuvante em depressão. No consultório, costuma importar menos a indicação formal e mais a mudança no padrão da sessão nas primeiras 1 a 3 semanas, quando podem aparecer inquietação, alteração do sono, oscilação de energia ou sedação; parte dos efeitos subjetivos tende a se acomodar ao longo das semanas seguintes. Quando há benefício, ele pode surgir como maior organização, redução de reatividade ou menor intensidade de ideias delirantes, mas isso pode se confundir com melhora espontânea, contexto de vida ou adesão irregular. O ponto central é diferenciar ativação medicamentosa, estabilização clínica e possível virada de humor.

O paciente pode relatar

- **"Ativação interna:** Uma parte dos pacientes passa a chegar mais inquieta, com dificuldade de permanecer sentada, sensação de urgência corporal ou irritabilidade sem objeto claro. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, agitação por estresse recente ou traço de personalidade mais impulsivo, mas vale notar se houve mudança nítida após o início ou retomada do medicamento. Quando a pessoa descreve desconforto físico de ficar parada mais do que preocupação antecipatória, a leitura clínica muda e pode justificar registro mais preciso e eventual alinhamento com o médico.

Sono e ritmo: O sono pode se desorganizar para mais ou para menos, sobretudo no começo: alguns pacientes relatam insônia, redução da necessidade percebida de dormir ou sono mais fragmentado; outros aparecem mais lentificados ou sonolentos. Isso pode se confundir tanto com piora depressiva quanto com melhora de um quadro previamente muito acelerado, além de sofrer influência de cafeína, rotina, uso de outras medicações e horários irregulares. Observar a relação entre mudança do sono, energia diurna e qualidade do contato na sessão costuma ajudar mais do que tomar o sintoma isoladamente.

Humor e reatividade: Ao longo das semanas, pode haver redução de irritabilidade, menor intensidade de ideias persecutórias ou mais capacidade de freio antes de agir, o que às vezes melhora o trabalho terapêutico. Em contrapartida, uma elevação de energia com expansividade, autoconfiança incomum e menor crítica pode ser lida apressadamente como melhora, quando talvez sinalize descompensação do humor. Eventos de vida positivos, alívio após crise aguda e adesão parcial também podem produzir uma aparência de melhora que não se sustenta entre sessões.

Cognição e presença: Alguns pacientes ficam mais organizados, acessíveis e capazes de sustentar linha de pensamento; outros parecem mais vagos, lentos ou com menor espontaneidade. Na prática clínica, isso pode ser confundido com embotamento do quadro de base, efeito de privação de sono, uso concomitante de sedativos ou retraimento defensivo no vínculo. Vale comparar com a baseline do paciente: se a fala perdeu riqueza afetiva e nuance ao mesmo tempo em que houve redução de desorganização, a sessão pede uma leitura mais fina do que simplesmente 'melhorou' ou 'piorou'.

Adesão e oscilação: Por ser um medicamento cujo uso irregular pode produzir mudanças perceptíveis no padrão da sessão, convém acompanhar discretamente esquecimentos, interrupções por conta própria e retomadas intermitentes. O paciente pode atribuir a oscilação a conflitos, trabalho ou relações, enquanto o terapeuta nota alternância entre maior organização e retorno de inquietação, irritabilidade ou estranheza do pensamento. Quando a adesão é ego-distônica por efeitos incômodos ou por ambivalência em relação ao tratamento, o risco maior no consultório é interpretar como resistência psíquica algo que também pode estar ligado ao uso inconsistente.

Sinais extrapiramidais: Embora menos proeminentes do que com outros antipsicóticos, podem aparecer tremor fino, rigidez subjetiva, face menos móvel ou desconforto motor que interfere na presença em sessão. Esses sinais às vezes são lidos como ansiedade, retraimento, efeito do próprio transtorno ou até desinteresse pelo encontro. Quando o corpo parece mais travado ou

inquieto do que o conteúdo emocional justificaria, vale descrever concretamente o observado e verificar se isso coincide com mudanças recentes no tratamento."

O que observar em sessão

- **Ativação interna:** Uma parte dos pacientes passa a chegar mais inquieta, com dificuldade de permanecer sentada, sensação de urgência corporal ou irritabilidade sem objeto claro. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, agitação por estresse recente ou traço de personalidade mais impulsivo, mas vale notar se houve mudança nítida após o início ou retomada do medicamento. Quando a pessoa descreve desconforto físico de ficar parada mais do que preocupação antecipatória, a leitura clínica muda e pode justificar registro mais preciso e eventual alinhamento com o médico.

Sono e ritmo: O sono pode se desorganizar para mais ou para menos, sobretudo no começo: alguns pacientes relatam insônia, redução da necessidade percebida de dormir ou sono mais fragmentado; outros aparecem mais lentificados ou sonolentos. Isso pode se confundir tanto com piora depressiva quanto com melhora de um quadro previamente muito acelerado, além de sofrer influência de cafeína, rotina, uso de outras medicações e horários irregulares. Observar a relação entre mudança do sono, energia diurna e qualidade do contato na sessão costuma ajudar mais do que tomar o sintoma isoladamente.

Humor e reatividade: Ao longo das semanas, pode haver redução de irritabilidade, menor intensidade de ideias persecutórias ou mais capacidade de freio antes de agir, o que às vezes melhora o trabalho terapêutico. Em contrapartida, uma elevação de energia com expansividade, autoconfiança incomum e menor crítica pode ser lida apressadamente como melhora, quando talvez sinalize descompensação do humor. Eventos de vida positivos, alívio após crise aguda e adesão parcial também podem produzir uma aparência de melhora que não se sustenta entre sessões.

Cognição e presença: Alguns pacientes ficam mais organizados, acessíveis e capazes de sustentar linha de pensamento; outros parecem mais vagos, lentos ou com menor espontaneidade. Na prática clínica, isso pode ser confundido com embotamento do quadro de base, efeito de privação de sono, uso concomitante de sedativos ou retraimento defensivo no vínculo. Vale comparar com a baseline do paciente: se a fala perdeu riqueza afetiva e nuance ao mesmo tempo em que houve redução de desorganização, a sessão pede uma leitura mais fina do que simplesmente 'melhorou' ou 'piorou'.

Adesão e oscilação: Por ser um medicamento cujo uso irregular pode produzir mudanças perceptíveis no padrão da sessão, convém acompanhar discretamente esquecimentos, interrupções por conta própria e retomadas intermitentes. O paciente pode atribuir a oscilação a conflitos, trabalho ou relações, enquanto o terapeuta nota alternância entre maior organização e retorno de inquietação, irritabilidade ou estranheza do pensamento. Quando a adesão é ego-distônica por efeitos incômodos ou por ambivalência em relação ao tratamento, o risco maior no consultório é interpretar como resistência psíquica algo que também pode estar ligado ao uso inconsistente.

Sinais extrapiramidais: Embora menos proeminentes do que com outros antipsicóticos, podem aparecer tremor fino, rigidez subjetiva, face menos móvel ou desconforto motor que interfere na presença em sessão. Esses sinais às vezes são lidos como ansiedade, retraimento, efeito do próprio transtorno ou até desinteresse pelo encontro. Quando o corpo parece mais travado ou

inquieto do que o conteúdo emocional justificaria, vale descrever concretamente o observado e verificar se isso coincide com mudanças recentes no tratamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Aripiprazol é um antipsicótico usado em quadros como transtorno bipolar, esquizofrenia, irritabilidade associada ao autismo e, em alguns casos, como adjuvante em depressão. No consultório, costuma importar menos a indicação formal e mais a mudança no padrão da sessão nas primeiras 1 a 3 semanas, quando podem aparecer inquietação, alteração do sono, oscilação de energia ou sedação; parte dos efeitos subjetivos tende a se acomodar ao longo das semanas seguintes. Quando há benefício, ele pode surgir como maior organização, redução de reatividade ou menor intensidade de ideias delirantes, mas isso pode se confundir com melhora espontânea, contexto de vida ou adesão irregular. O ponto central é diferenciar ativação medicamentosa, estabilização clínica e possível virada de humor.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está mais agitado, isso parece vir de pensamentos acelerados e preocupação ou de uma sensação física de não conseguir ficar parado? , Essa melhora que você percebe veio com mais clareza e estabilidade ou junto com menos sono, mais impulsividade e uma confiança fora do seu padrão? , Nos dias em que você se sente mais estranho ou mais irritado, isso varia conforme situações do dia ou aparece mesmo quando o contexto está parecido? , Você nota que sua dificuldade de concentração se parece mais com cansaço e lentidão ou com uma aceleração em que sua atenção salta de uma coisa para outra? , Quando você faltou, esqueceu ou mudou a forma de tomar por conta própria, percebeu alguma mudança no seu corpo, no sono ou no jeito de pensar nos dias seguintes? , Essa sensação de estar mais 'apagado' vem com alívio do sofrimento ou com perda de interesse, menos acesso afetivo e sensação de estar distante de si mesmo?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar inquietação corporal persistente
- dificuldade de permanecer sentado ou irritabilidade nova que interfere na sessão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar ativação medicamentosa de piora do quadro
- Quando surge redução importante do sono acompanhada de expansividade
- impulsividade
- aumento de planos ou autoconfiança fora da baseline
- pode valer comunicar o médico pela possibilidade de desorganização do humor
- Quando a pessoa interrompe
- esquece com frequência ou retoma o uso de forma irregular e o padrão clínico oscila entre sessões
- pode valer contato com o psiquiatra para contextualizar a leitura da evolução
- Quando aparecem rigidez

Amarelo: alinhar em breve

- tremor
- travamento corporal ou desconforto motor que o paciente não nomeava antes
- pode valer alinhar com o médico para avaliação de tolerabilidade
- Quando
- após algumas semanas
- não se observa qualquer ganho clínico e o paciente segue muito comprometido ou mais desconfiado
- pode valer comunicar o psiquiatra para atualização do quadro observado em psicoterapia

Vermelho: tratar como urgência

- Redução acentuada da necessidade de sono junto com aceleração importante
- grandiosidade
- impulsividade ou comportamento claramente fora do padrão habitual.: Acionar o psiquiatra no mesmo dia e avaliar necessidade de envolver rede de apoio e recursos de urgência conforme o grau de desorganização e risco
- Aparecimento ou intensificação de ideação suicida
- sobretudo quando coincide com início recente
- piora de agitação ou sensação de desespero intolerável.: Fazer avaliação imediata de risco
- acionar psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhar para emergência se houver risco iminente
- Paciente chega muito confuso
- febril
- suando
- com rigidez importante ou rebaixamento acentuado do estado geral.: Tratar como urgência clínica
- orientar busca imediata de avaliação médica de emergência e comunicar o psiquiatra

Frase clínica

O foco é distinguir inquietação e ativação do aripiprazol de ansiedade habitual, melhora real do quadro e possível virada de humor.

060 BREXPIPAZOL

Substância: Brexpiprazol.

Nomes Comerciais: Rexulti

Uso comum

- Brexpiprazol é um antipsicótico usado em alguns quadros psicóticos e, em certos contextos, como adjuvante em depressão. No consultório, costuma importar menos a indicação formal e mais como o paciente muda nas primeiras 1 a 4 semanas: pode haver alteração de energia, inquietação, sonolência, lentificação subjetiva ou redução da intensidade de ideias e reatividade. Em algumas semanas a poucos meses, vale acompanhar se houve ganho funcional real ou apenas contenção do sofrimento às custas de embotamento. O ponto central na sessão é discriminar melhora clínica de apaziguamento excessivo, além de notar sinais de adesão irregular, que podem aparecer como oscilação abrupta do padrão entre sessões.

O paciente pode relatar

- **"Ativação inquieta:** Em parte dos pacientes, surge uma inquietação corporal difícil de nomear: a pessoa diz que está mais ansiosa, mas na sessão aparece mexendo pernas, mudando de posição ou referindo incômodo de ficar parada. Isso pode se confundir com ansiedade basal, agitação ligada a estresse recente ou melhora parcial com mais energia disponível. A pista clínica é a qualidade mais física e menos ideativa do desconforto, sobretudo quando o padrão mudou após o início do medicamento ou oscila com adesão irregular.

Sedação e ritmo: Alguns pacientes ficam mais sonolentos, lentos ou com menor vivacidade associativa, o que pode aparecer como fala mais pausada, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar elaboração. Na sessão, isso pode parecer piora depressiva, exaustão por rotina ou efeito de outras medicações sedativas. Vale observar se há preservação do humor de base com queda do ritmo, ou se a lentificação vem junto de desesperança, anedonia e retraimento mais amplos.

Embotamento afetivo: Quando o sofrimento perde intensidade, pode haver alívio genuíno; em outros casos, o paciente descreve estar menos mal, porém mais distante de si, com acesso afetivo achatado e menor ressonância emocional. O terapeuta pode notar narrativa correta, porém pouco implicada, com redução da reatividade inclusive diante de temas antes mobilizadores. Isso se confunde facilmente com estabilização do quadro, defesa dissociativa ou esgotamento emocional, então importa comparar com a baseline do vínculo e da expressividade prévia.

Cognição e presença: Pode aparecer sensação de cabeça mais lenta, dificuldade de organizar pensamento ou menor agilidade para acompanhar a sessão, especialmente no início ou quando há outras medicações em uso. Em quadros psicóticos, isso pode ser lido como persistência do transtorno; em depressão, como piora cognitiva do episódio; em pacientes sobrecarregados, como efeito de privação de sono e estresse. A discriminação depende de notar se a desorganização diminuiu enquanto a velocidade mental caiu, ou se ambos pioraram juntos.

Adesão e oscilação: Como o uso irregular nem sempre é espontaneamente relatado, o terapeuta pode perceber mudanças abruptas entre sessões: um encontro com maior contenção e lentificação, outro com retorno de inquietação, insônia ou intensificação de ideias. Essas oscilações podem ser atribuídas a eventos de vida, uso de substâncias ou flutuação do quadro de base. Quando o padrão muda de forma pouco coerente com o contexto narrado, vale explorar concretamente como o paciente tem conseguido manter a rotina do tratamento.

Virada de humor: Se o brexpiprazol estiver em contexto de depressão, especialmente com antidepressivo associado, importa observar aceleração incomum do humor e do comportamento. Na sessão, isso pode surgir como fala mais rápida, redução importante do sono sem cansaço, autoconfiança expansiva, irritabilidade nova ou aumento de impulsividade, o que pode ser confundido com melhora legítima. O critério clínico útil é a perda de proporção: não apenas estar melhor, mas estar diferente do próprio padrão, com maior risco e menor autocrítica."

O que observar em sessão

- **Ativação inquieta:** Em parte dos pacientes, surge uma inquietação corporal difícil de nomear: a pessoa diz que está mais ansiosa, mas na sessão aparece mexendo pernas, mudando de posição ou referindo incômodo de ficar parada. Isso pode se confundir com ansiedade basal, agitação ligada a estresse recente ou melhora parcial com mais energia disponível. A pista clínica é a qualidade mais física e menos ideativa do desconforto, sobretudo quando o padrão mudou após o início do medicamento ou oscila com adesão irregular.

Sedação e ritmo: Alguns pacientes ficam mais sonolentos, lentos ou com menor vivacidade associativa, o que pode aparecer como fala mais pausada, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar elaboração. Na sessão, isso pode parecer piora depressiva, exaustão por rotina ou efeito de outras medicações sedativas. Vale observar se há preservação do humor de base com queda do ritmo, ou se a lentificação vem junto de desesperança, anedonia e retraimento mais amplos.

Embotamento afetivo: Quando o sofrimento perde intensidade, pode haver alívio genuíno; em outros casos, o paciente descreve estar "menos mal", porém mais distante de si, com acesso afetivo achatado e menor ressonância emocional. O terapeuta pode notar narrativa correta, porém pouco implicada, com redução da reatividade inclusive diante de temas antes mobilizadores. Isso se confunde facilmente com estabilização do quadro, defesa dissociativa ou esgotamento emocional, então importa comparar com a baseline do vínculo e da expressividade prévia.

Cognição e presença: Pode aparecer sensação de cabeça mais lenta, dificuldade de organizar pensamento ou menor agilidade para acompanhar a sessão, especialmente no início ou quando há outras medicações em uso. Em quadros psicóticos, isso pode ser lido como persistência do transtorno; em depressão, como piora cognitiva do episódio; em pacientes sobrecarregados, como efeito de privação de sono e estresse. A discriminação depende de notar se a desorganização diminuiu enquanto a velocidade mental caiu, ou se ambos pioraram juntos.

Adesão e oscilação: Como o uso irregular nem sempre é espontaneamente relatado, o terapeuta pode perceber mudanças abruptas entre sessões: um encontro com maior contenção e lentificação, outro com retorno de inquietação, insônia ou intensificação de ideias. Essas oscilações podem ser atribuídas a eventos de vida, uso de substâncias ou flutuação do quadro de base. Quando o padrão muda de forma pouco coerente com o contexto narrado, vale explorar concretamente como o paciente tem conseguido manter a rotina do tratamento.

Virada de humor: Se o brexpiprazol estiver em contexto de depressão, especialmente com antidepressivo associado, importa observar aceleração incomum do humor e do comportamento. Na sessão, isso pode surgir como fala mais rápida, redução importante do sono sem cansaço, autoconfiança expansiva, irritabilidade nova ou aumento de impulsividade, o que pode ser confundido com melhora legítima. O critério clínico útil é a perda de proporção: não apenas estar melhor, mas estar diferente do próprio padrão, com maior risco e menor autocrítica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Brexpiprazol é um antipsicótico usado em alguns quadros psicóticos e, em certos contextos, como adjuvante em depressão. No consultório, costuma importar menos a indicação formal e mais como o paciente muda nas primeiras 1 a 4 semanas: pode haver alteração de energia, inquietação, sonolência, lentificação subjetiva ou redução da intensidade de ideias e reatividade. Em algumas semanas a poucos meses, vale acompanhar se houve ganho funcional real ou apenas contenção do sofrimento às custas de embotamento. O ponto central na sessão é discriminar melhora clínica de apaziguamento excessivo, além de notar sinais de adesão irregular, que podem aparecer como oscilação abrupta do padrão entre sessões.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está mais ansioso, isso vem mais como preocupação e pensamentos acelerados ou como um incômodo no corpo, de não conseguir ficar parado? , Desde que começou a medicação, você se sente realmente melhor por dentro ou mais amortecido, como se as coisas batessem menos mas você também ficasse menos você? , Essa lentidão que apareceu parece vir junto de tristeza e falta de esperança, ou é mais um corpo e uma cabeça em ritmo mais baixo apesar de o humor não ter piorado tanto? , Nas últimas semanas, as mudanças entre um dia e outro combinam com o que estava acontecendo na sua vida ou parecem mudanças mais bruscas, difíceis de explicar pelo contexto? , Quando seu sono diminuiu ou sua energia subiu, isso veio com sensação boa e organizada ou com aceleração, irritação, impulsividade ou ideias grandiosas fora do seu padrão? , Nos dias em que você se sente diferente, isso costuma acontecer de modo relativamente contínuo ou alterna bastante, como se houvesse dias muito distintos sem uma razão clara?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta inquietação corporal persistente que começa a atrapalhar permanência na sessão
- sono ou rotina
- pode valer alinhar com o psiquiatra para avaliar tolerabilidade e risco de abandono silencioso
- Quando surge embotamento afetivo importante
- com redução do sofrimento mas também perda de implicação
- prazer e responsividade interpessoal
- pode valer comunicar o médico para diferenciar melhora parcial de apaziguamento excessivo
- Quando há sonolência
- lentificação ou queda de presença mental que passam a comprometer trabalho
- direção
- cuidado com filhos ou participação na terapia
- pode valer contato com o psiquiatra pela repercussão funcional
- Quando o paciente descreve uso irregular
- esquecimentos frequentes ou interrupções por conta própria

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico porque a leitura da evolução clínica fica mais incerta e o risco de oscilação aumenta
- Quando aparecem sinais de aceleração de humor fora do padrão
- sobretudo em contexto de depressão tratada
- pode valer comunicação com o psiquiatra para esclarecer se houve mudança relevante do estado mental
- Quando
- após algumas semanas a poucos meses
- não se observa ganho funcional compatível com a proposta do tratamento e o paciente segue muito sintomático
- pode valer compartilhar a impressão clínica para reavaliação do quadro

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecimento de ideias de morte ou piora importante de ideação suicida
- especialmente se vier junto de agitação
- impulsividade ou sensação de estar fora do próprio eixo.: Fazer avaliação de risco na sessão e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Mudança acentuada para fala muito acelerada
- redução importante da necessidade de sono
- expansividade ou irritabilidade com perda de crítica e aumento de condutas de risco.: Tratar como mudança aguda do estado mental e buscar contato médico no mesmo dia
- com apoio da rede e avaliação de segurança
- Febre
- rigidez importante
- confusão marcante ou rebaixamento acentuado do estado geral percebidos na sessão ou relatados como instalação recente.: Orientar busca de avaliação médica urgente no mesmo dia e acionar suporte de emergência se houver comprometimento importante

Frase clínica

O foco é distinguir contenção útil do sofrimento de inquietação, embotamento ou lentificação que mudam o padrão do paciente e a leitura da sessão.

061 CLORIDRATO DE LURASIDONA

Substância: Cloridrato de Lurasidona.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Lurasidona, Luratt, Latuda®, Lutab, Lubip

Uso comum

- A lurasidona é um antipsicótico usado sobretudo em quadros do espectro bipolar e esquizofrenia, às vezes em fases em que o terapeuta acompanha oscilação de humor, retraimento, desorganização do pensamento ou maior vulnerabilidade psicótica. Nas primeiras 1 a 3 semanas, vale observar mais de perto sedação, inquietação corporal, náusea e mudanças no ritmo da sessão; entre 2 e 6 semanas, pode começar a ficar mais claro se há redução de agitação, melhora do contato e maior organização. O ponto central no consultório é diferenciar melhora clínica de embotamento, ansiedade de acatisia e piora do quadro de base de adesão irregular ou abandono silencioso por desconforto.

O paciente pode relatar

- **"Inquietação corporal:** Alguns pacientes passam a chegar mais agitados no corpo do que no conteúdo: mudam de posição, balançam pernas, levantam-se com frequência ou descrevem um incômodo difícil de nomear, como se não conseguissem ficar parados. Na sessão, isso pode se confundir com ansiedade habitual, ativação por estresse recente ou aumento de tensão interpessoal. A pista útil costuma estar na qualidade mais motora e pouco elaborável da experiência, especialmente quando surge após início recente ou uso irregular.

Sedação e ritmo: Pode aparecer lentificação, sonolência, menor espontaneidade e redução do fôlego associativo, às vezes com empobrecimento temporário da sessão. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, retraimento defensivo ou desinvestimento do processo terapêutico. Vale comparar com a linha de base, com o horário em que o paciente costuma ser atendido e com mudanças recentes na rotina, porque a apresentação pode oscilar bastante de um encontro para outro.

Acesso afetivo: Quando há melhora parcial do quadro, o paciente pode ficar menos tomado por angústia, irritabilidade ou desorganização, mas em parte dos casos isso vem acompanhado de relato de estar mais apagado ou menos ele mesmo. Na sessão, o desafio é distinguir redução de sofrimento e maior continência psíquica de embotamento afetivo que empobrece a elaboração. Eventos de vida, exaustão e uso concomitante de outras medicações também podem produzir uma aparência semelhante.

Organização do pensamento: Com a evolução favorável, tende a haver mais linearidade, menor dispersão e melhor capacidade de sustentar um tema sem se perder tanto em associações idiossincráticas ou suspeitas excessivas. Quando isso não aparece após algumas semanas, ou quando há oscilação marcada entre sessões, entram no radar adesão irregular, uso intermitente por desconforto e flutuação do próprio quadro. Também vale lembrar que melhora cognitiva aparente pode coexistir com empobrecimento subjetivo, o que muda o manejo clínico da sessão.

Humor e virada: Em pacientes com transtorno bipolar ou vulnerabilidade a oscilação de humor, a sessão pode trazer tanto redução de irritabilidade e impulsividade quanto sinais de aceleração que não combinam com simples melhora. Fala mais pressionada, diminuição importante da necessidade de sono, expansividade incomum e aumento de projetos podem refletir mudança do estado de humor mais do que resposta terapêutica estável. A leitura fica mais difícil quando há alívio após episódio depressivo, porque o contraste pode parecer apenas recuperação.

Adesão silenciosa: A lurasidona pode ser abandonada sem anúncio claro quando o paciente sente desconforto corporal, sonolência, náusea ou a impressão de estar estranho, sobretudo se já tem relação ambivalente com tratamento medicamentoso. Na terapia, isso costuma aparecer indiretamente: faltas, oscilação abrupta entre sessões, respostas vagas sobre rotina e mudança súbita no padrão de sintomas. Diferenciar interrupção, tomada irregular e piora espontânea do quadro ajuda a evitar interpretações exclusivamente transferenciais de uma mudança que também pode ser clínica."

O que observar em sessão

- **Inquietação corporal:** Alguns pacientes passam a chegar mais agitados no corpo do que no conteúdo: mudam de posição, balançam pernas, levantam-se com frequência ou descrevem um incômodo difícil de nomear, como se não conseguissem ficar parados. Na sessão, isso pode se confundir com ansiedade habitual, ativação por estresse recente ou aumento de tensão interpessoal. A pista útil costuma estar na qualidade mais motora e pouco elaborável da experiência, especialmente quando surge após início recente ou uso irregular.

Sedação e ritmo: Pode aparecer lentificação, sonolência, menor espontaneidade e redução do fôlego associativo, às vezes com empobrecimento temporário da sessão. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, retraimento defensivo ou desinvestimento do processo terapêutico. Vale comparar com a linha de base, com o horário em que o paciente costuma ser atendido e com mudanças recentes na rotina, porque a apresentação pode oscilar bastante de um encontro para outro.

Acesso afetivo: Quando há melhora parcial do quadro, o paciente pode ficar menos tomado por angústia, irritabilidade ou desorganização, mas em parte dos casos isso vem acompanhado de relato de estar "mais apagado" ou "menos ele mesmo". Na sessão, o desafio é distinguir redução de sofrimento e maior continência psíquica de embotamento afetivo que empobrece a elaboração. Eventos de vida, exaustão e uso concomitante de outras medicações também podem produzir uma aparência semelhante.

Organização do pensamento: Com a evolução favorável, tende a haver mais linearidade, menor dispersão e melhor capacidade de sustentar um tema sem se perder tanto em associações idiossincráticas ou suspeitas excessivas. Quando isso não aparece após algumas semanas, ou quando há oscilação marcada entre sessões, entram no radar adesão irregular, uso intermitente por desconforto e flutuação do próprio quadro. Também vale lembrar que melhora cognitiva aparente pode coexistir com empobrecimento subjetivo, o que muda o manejo clínico da sessão.

Humor e virada: Em pacientes com transtorno bipolar ou vulnerabilidade a oscilação de humor, a sessão pode trazer tanto redução de irritabilidade e impulsividade quanto sinais de aceleração que não combinam com simples melhora. Fala mais pressionada, diminuição importante da necessidade de sono, expansividade incomum e aumento de projetos podem refletir mudança do estado de humor mais do que resposta terapêutica estável. A leitura fica mais difícil quando há alívio após episódio depressivo, porque o contraste pode parecer apenas recuperação.

Adesão silenciosa: A lurasidona pode ser abandonada sem anúncio claro quando o paciente sente desconforto corporal, sonolência, náusea ou a impressão de estar estranho, sobretudo se já tem relação ambivalente com tratamento medicamentoso. Na terapia, isso costuma aparecer indiretamente: faltas, oscilação abrupta entre sessões, respostas vagas sobre rotina e mudança súbita no padrão de sintomas. Diferenciar interrupção, tomada irregular e piora espontânea do quadro ajuda a evitar interpretações exclusivamente transferenciais de uma mudança que também pode ser clínica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A lurasidona é um antipsicótico usado sobretudo em quadros do espectro bipolar e esquizofrenia, às vezes em fases em que o terapeuta acompanha oscilação de humor, retraimento, desorganização do pensamento ou maior vulnerabilidade psicótica. Nas primeiras 1 a 3 semanas, vale observar mais de perto sedação, inquietação corporal, náusea e mudanças no ritmo da sessão; entre 2 e 6 semanas, pode começar a ficar mais claro se há redução de agitação, melhora do contato e maior organização. O ponto central no consultório é diferenciar melhora clínica de embotamento, ansiedade de acatisia e piora do quadro de base de adesão irregular ou abandono silencioso por desconforto.

Perguntas úteis

- "Quando essa agitação aparece, você sente mais pensamentos de preocupação e medo ou é mais uma sensação física de não conseguir ficar parado mesmo sem um motivo claro? , Esse cansaço que você percebe vem com tristeza, desesperança e perda de interesse, ou parece mais um corpo pesado e uma lentidão que não combina tanto com o seu humor? , Você sente que está sofrendo menos e conseguindo pensar melhor, ou ficou mais indiferente, como se as coisas importassem menos inclusive as que antes eram significativas para você? , Nas últimas semanas, sua fala, seus planos e sua necessidade de sono mudaram junto com uma sensação de estar especialmente acelerado, ou você percebe isso mais como alívio depois de um período muito ruim? , Quando você piora de um encontro para outro, isso aconteceu junto de alguma mudança na forma como tem tomado a medicação ou pareceu vir mesmo mantendo a rotina igual?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a descrever inquietação corporal persistente
- com dificuldade de permanecer sentado e impacto claro no funcionamento
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar ansiedade do quadro de um efeito que favoreça abandono silencioso
- Quando surge sonolência importante
- lentificação ou empobrecimento da sessão que não estavam na linha de base
- pode valer comunicar o médico assistente para situar o quanto isso está interferindo na adesão e na vida diária
- Quando aparecem sinais de aceleração do humor
- redução importante do sono
- expansividade ou aumento de impulsividade
- pode valer contato com o psiquiatra para checar mudança de estado clínico
- Quando há oscilação abrupta entre sessões
- piora após período de aparente estabilidade ou respostas muito vagas sobre uso regular
- pode valer alinhar com o médico pela possibilidade de adesão irregular
- Quando
- após 4 a 6 semanas

Amarelo: alinhar em breve

- não se observa nenhuma melhora em organização
- contato ou redução de sofrimento
- pode valer comunicar o psiquiatra para compartilhar a evolução clínica observada no consultório

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem fala muito acelerada
- redução acentuada da necessidade de sono
- expansividade incomum
- impulsividade ou sensação de estar "ligado demais" em relação ao padrão habitual.: Tratar como mudança aguda do estado clínico
- acionar o psiquiatra no mesmo dia e ampliar avaliação de risco e rede de apoio
- O paciente chega muito confuso
- intensamente desconfiado
- ouvindo ou vendo coisas com forte perda de crítica
- ou sem conseguir sustentar autocuidado básico.: Priorizar segurança
- contatar o psiquiatra imediatamente e acionar rede de apoio e emergência se a contenção ambulatorial não parecer suficiente
- Surge ideação suicida com intenção
- plano
- aumento de desesperança ou piora rápida do juízo crítico
- sobretudo em contexto de agitação ou desorganização.: Fazer manejo de risco no mesmo atendimento
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

Na terapia, o foco com lurasidona é separar melhora de organização psíquica de embotamento, acatisia e adesão irregular.

062 CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA

Substância: Cloridrato de Ziprasidona.

Nomes Comerciais: Geodon, Cloridrato de Ziprasidona

Uso comum

- A ziprasidona é um antipsicótico usado sobretudo em quadros psicóticos e em fases de humor com agitação, podendo também aparecer em manutenção. No consultório, as primeiras 1 a 2 semanas costumam concentrar mudanças mais perceptíveis de tolerabilidade e ritmo subjetivo; entre 2 e 6 semanas já pode ficar mais claro se houve redução de desorganização, irritabilidade ou aceleração. O ponto central para o terapeuta é diferenciar melhora clínica de sedação excessiva, inquietação corporal ou adesão irregular, porque esses fatores podem alterar muito a qualidade da sessão e a leitura da evolução.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter mais lentificação, sonolência, fala menos espontânea ou dificuldade de sustentar elaboração, especialmente no início do uso ou após mudanças recentes na rotina de tomada. Isso pode ser confundido com retraimento depressivo, exaustão por insônia prévia ou esgotamento ligado ao próprio quadro de base. Vale observar se a redução de produtividade psíquica vem acompanhada de menor sofrimento e maior organização, ou se parece mais um rebaixamento do estado de alerta que empobrece o contato.

Inquietação corporal: Alguns pacientes descrevem um incômodo de ficar parado, necessidade de mudar de posição, andar ou balançar as pernas, às vezes nomeado como ansiedade. Na sessão, isso pode se apresentar como agitação motora sem aumento correspondente de conteúdo ansioso, o que confunde a leitura com ansiedade habitual, tensão situacional ou ativação do próprio episódio de humor. A discriminação depende de notar se o mal-estar é mais corporal do que psíquico e se surgiu em proximidade temporal com o início do tratamento ou com adesão irregular.

Organização do pensamento: Quando há resposta clínica, pode surgir maior linearidade do discurso, menos dispersão, menor pressão para falar e melhor capacidade de acompanhar a conversa ao longo de algumas semanas. Essa melhora às vezes convive com certo empobrecimento subjetivo, e o terapeuta pode hesitar entre ler como estabilização útil ou como apagamento excessivo. Também é fácil confundir flutuações de organização com privação de sono, uso de outras substâncias ou tomada intermitente da medicação.

Humor e ativação: Em pacientes com quadros de humor, a ziprasidona pode vir acompanhada de redução de irritabilidade, impulsividade e aceleração, mas a sessão pode mostrar uma transição irregular antes de estabilizar. Se o paciente parece menos expansivo, vale diferenciar contenção terapêutica de desânimo, embotamento ou simples efeito de cansaço. Eventos de vida, conflitos interpessoais e noites mal dormidas podem produzir oscilações que imitam tanto melhora quanto piora.

Adesão e continuidade: A adesão irregular costuma aparecer menos como informação espontânea e mais como mudanças abruptas no padrão da sessão: um encontro mais organizado seguido de outro com retorno de confusão, agitação ou sonolência atípica. O paciente pode omitir falhas por vergonha, ambivalência com o tratamento ou por não ligar a oscilação ao uso inconsistente. Para o terapeuta, o ponto não é confirmar causa, mas registrar a cronologia entre mudanças subjetivas, rotina diária e variações do funcionamento.

Sinais físicos na sessão: Embora o consultório não seja lugar de exame físico, às vezes aparecem queixas de palpitações, tontura, sensação de desmaio iminente ou mal-estar inespecífico que alteram a presença do paciente na sessão. Esses sinais podem ter múltiplas leituras, incluindo ansiedade aguda, jejum, outras medicações ou condições clínicas não relacionadas. Ainda assim, quando surgem de modo novo ou em conjunto, merecem atenção porque podem interferir na segurança e na continuidade do acompanhamento."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter mais lentificação, sonolência, fala menos espontânea ou dificuldade de sustentar elaboração, especialmente no início do uso ou após mudanças recentes na rotina de tomada. Isso pode ser confundido com retraimento depressivo, exaustão por insônia prévia ou esgotamento ligado ao próprio quadro de base. Vale observar se a redução de produtividade psíquica vem acompanhada de menor sofrimento e maior organização, ou se parece mais um rebaixamento do estado de alerta que empobrece o contato.

Inquietação corporal: Alguns pacientes descrevem um incômodo de ficar parado, necessidade de mudar de posição, andar ou balançar as pernas, às vezes nomeado como ansiedade. Na sessão, isso pode se apresentar como agitação motora sem aumento correspondente de conteúdo ansioso, o que confunde a leitura com ansiedade habitual, tensão situacional ou ativação do próprio episódio de humor. A discriminação depende de notar se o mal-estar é mais corporal do que psíquico e se surgiu em proximidade temporal com o início do tratamento ou com adesão irregular.

Organização do pensamento: Quando há resposta clínica, pode surgir maior linearidade do discurso, menos dispersão, menor pressão para falar e melhor capacidade de acompanhar a conversa ao longo de algumas semanas. Essa melhora às vezes convive com certo empobrecimento subjetivo, e o terapeuta pode hesitar entre ler como estabilização útil ou como apagamento excessivo. Também é fácil confundir flutuações de organização com privação de sono, uso de outras substâncias ou tomada intermitente da medicação.

Humor e ativação: Em pacientes com quadros de humor, a ziprasidona pode vir acompanhada de redução de irritabilidade, impulsividade e aceleração, mas a sessão pode mostrar uma transição irregular antes de estabilizar. Se o paciente parece menos expansivo, vale diferenciar contenção terapêutica de desânimo, embotamento ou simples efeito de cansaço. Eventos de vida, conflitos interpessoais e noites mal dormidas podem produzir oscilações que imitam tanto melhora quanto piora.

Adesão e continuidade: A adesão irregular costuma aparecer menos como informação espontânea e mais como mudanças abruptas no padrão da sessão: um encontro mais organizado seguido de outro com retorno de confusão, agitação ou sonolência atípica. O paciente pode omitir falhas por vergonha, ambivalência com o tratamento ou por não ligar a oscilação ao uso inconsistente. Para o terapeuta, o ponto não é confirmar causa, mas registrar a cronologia entre mudanças subjetivas, rotina diária e variações do funcionamento.

Sinais físicos na sessão: Embora o consultório não seja lugar de exame físico, às vezes aparecem queixas de palpitações, tontura, sensação de desmaio iminente ou mal-estar inespecífico que alteram a presença do paciente na sessão. Esses sinais podem ter múltiplas leituras, incluindo ansiedade aguda, jejum, outras medicações ou condições clínicas não relacionadas. Ainda assim, quando surgem de modo novo ou em conjunto, merecem atenção porque podem interferir na segurança e na continuidade do acompanhamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A ziprasidona é um antipsicótico usado sobretudo em quadros psicóticos e em fases de humor com agitação, podendo também aparecer em manutenção. No consultório, as primeiras 1 a 2 semanas costumam concentrar mudanças mais perceptíveis de tolerabilidade e ritmo subjetivo; entre 2 e 6 semanas já pode ficar mais claro se houve redução de desorganização, irritabilidade ou aceleração. O ponto central para o terapeuta é diferenciar melhora clínica de sedação excessiva, inquietação corporal ou adesão irregular, porque esses fatores podem alterar muito a qualidade da sessão e a leitura da evolução.

Perguntas úteis

- "Quando essa agitação aparece, ela vem mais como preocupação e medo na cabeça ou como um incômodo no corpo de não conseguir ficar parado? , Você sente que está pensando com mais clareza e ficando mais organizado, ou mais devagar e meio apagado por dentro? , Nos dias em que chega mais sonolento ou mais confuso, isso costuma acontecer junto de noites ruins, mudanças na rotina ou falhas no uso da medicação? , Essa redução da irritabilidade parece vir com mais controle e reflexão, ou com menos acesso afetivo e menos interesse pelas coisas? , Quando seu funcionamento oscila de um dia para o outro, a mudança parece acompanhar acontecimentos da semana ou acontece sem um gatilho claro? , Esse mal-estar físico que você descreve vem junto de ansiedade parecida com a de costume, ou parece algo diferente do seu padrão habitual?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta sonolência persistente a ponto de empobrecer a sessão
- faltar compromissos ou reduzir muito a funcionalidade
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisar a tolerabilidade clínica
- Quando surge inquietação corporal importante
- especialmente se o paciente a descreve como insuportável ou passa a evitar ficar em ambientes fechados e sessões mais longas
- pode valer comunicar o médico para diferenciar efeito do tratamento de piora ansiosa
- Quando há oscilação marcada entre encontros
- com períodos de maior desorganização
- agitação ou retorno de sintomas após aparente melhora
- pode valer contato com o psiquiatra para informar possível adesão irregular ou resposta instável
- Quando o paciente relata palpitações
- tontura recorrente
- sensação de quase desmaio ou mal-estar físico novo que interfere na sessão
- pode valer alinhar com o médico pela necessidade de avaliação clínica
- Quando
- após algumas semanas

Amarelo: alinhar em breve

- não se observa qualquer ganho em organização
- redução de agitação ou estabilização do humor
- apesar de uso referido como regular
- pode valer comunicar o psiquiatra para compartilhar a impressão longitudinal do consultório

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecimento de fala muito acelerada
- redução importante da necessidade de sono
- expansividade incomum
- impulsividade ou sensação de estar 'bom demais' fora do padrão do paciente.: Tratar como mudança aguda de estado
- acionar o psiquiatra no mesmo dia e avaliar necessidade de envolver rede de apoio para proteção e monitoramento
- Palpitações intensas
- tontura importante
- sensação de desmaio iminente ou mal-estar súbito durante a sessão
- especialmente se o paciente parece fisicamente instável.: Interromper o trabalho clínico
- priorizar avaliação médica imediata e acionar emergência se houver risco clínico ou impossibilidade de locomoção segura
- Retorno abrupto de desorganização importante
- ideias persecutórias
- intensa agitação ou risco de autoagressão após interrupção referida ou provável uso muito irregular.: Avaliar segurança imediatamente
- acionar psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhar para urgência se o paciente não mantiver condições mínimas de autocuidado e proteção

Frase clínica

O foco é distinguir estabilização útil de sedação, inquietação corporal e adesão irregular que podem distorcer a leitura da evolução em sessão.

063 CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA MONOIDRATADO

Substância: Cloridrato de Ziprasidona Monoidratado.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Ziprasidona, Lfm Ziprasidona, Geodon

Uso comum

- A ziprasidona é um antipsicótico usado sobretudo em quadros psicóticos e em fases de humor com agitação ou aceleração, às vezes em manutenção. No consultório, as primeiras 1 a 3 semanas costumam concentrar mudanças mais visíveis de tolerabilidade e ritmo psíquico; ao longo de 2 a 6 semanas pode ficar mais claro se há redução de desorganização, irritabilidade, ideias persecutórias ou aceleração. O ponto central para o terapeuta é distinguir melhora do quadro de base de lentificação, inquietação corporal, sonolência ou embotamento que podem alterar a presença do paciente na sessão e afetar adesão silenciosa.

O paciente pode relatar

- **"Acatisia:** Alguns pacientes passam a chegar mais inquietos, mudando de posição, balançando pernas ou descrevendo um desconforto corporal difícil de nomear. Isso pode ser confundido com ansiedade habitual, agitação do próprio quadro ou tensão ligada a eventos recentes, especialmente se o conteúdo verbal parece menos ansioso do que o corpo sugere. Vale observar se a inquietação aparece como urgência física, pouco ligada a pensamentos específicos, e se coincide temporalmente com início, retomada irregular ou mudança recente no tratamento.

Sedação e ritmo: Pode surgir sonolência, lentificação, menor espontaneidade ou dificuldade de sustentar o fio associativo, sobretudo no começo do uso ou após adesão irregular. Na sessão, isso às vezes se parece com retraimento depressivo, exaustão por insônia prévia ou efeito de outras medicações sedativas, e a distinção depende de comparar com a baseline do paciente e com o horário em que ele costuma ficar mais rebaixado. Quando a presença fica mais opaca, vale discriminar se houve também redução de sofrimento e organização maior, ou apenas queda de vitalidade.

Organização do pensamento: Quando a medicação está ajudando, pode haver menos dispersão, menor pressão para falar, menos desconfiança e mais possibilidade de acompanhar a conversa sem se perder. Em parte dos casos, porém, uma fala mais curta ou menos carregada afetivamente pode ser lida como melhora quando há apenas contenção, cansaço ou empobrecimento subjetivo. O terapeuta ganha precisão ao comparar a qualidade do contato, a coerência narrativa e a capacidade de elaboração, em vez de tomar apenas a redução de intensidade como sinal inequívoco de estabilização.

Humor e ativação: Em pacientes com oscilação de humor, a sessão pode mostrar redução de irritabilidade e aceleração, mas também pode emergir um rebaixamento pouco elaborado, com menos energia e menos acesso afetivo. Eventos de vida, privação de sono e uso irregular podem produzir oscilações que parecem mudança medicamentosa. A leitura clínica fica mais segura quando se observa se a energia caiu junto com a impulsividade e a desorganização, ou se houve apenas apagamento com sofrimento ainda presente.

Adesão silenciosa: A ziprasidona pode ser abandonada ou usada de modo irregular quando o paciente sente desconforto corporal, sonolência, sensação de estar 'travado' ou quando melhora parcialmente e conclui que não precisa mais. Na terapia, isso costuma aparecer indiretamente: piora súbita após período melhor, narrativa vaga sobre rotina, oscilação entre sessões muito diferentes ou dificuldade em explicar mudanças recentes. Em vez de presumir recaída ou resistência, vale explorar com cuidado a regularidade do uso e o que o paciente tem feito diante dos efeitos percebidos.

Sinais físicos relevantes: Embora o foco da sessão não seja exame físico, às vezes aparecem palpitações, tontura, sensação de desmaio iminente ou mal-estar corporal inespecífico que o paciente associa pouco ao tratamento. Esses sinais podem ser confundidos com crise de ansiedade, hipervigilância somática ou exaustão, especialmente em pacientes já ansiosos. Quando surgem junto de fraqueza, instabilidade ao levantar ou mal-estar novo e persistente, convém registrar o contexto e considerar comunicação mais célere com o médico assistente."

O que observar em sessão

- **Acatisia:** Alguns pacientes passam a chegar mais inquietos, mudando de posição, balançando pernas ou descrevendo um desconforto corporal difícil de nomear. Isso pode ser confundido com ansiedade habitual, agitação do próprio quadro ou tensão ligada a eventos recentes, especialmente se o conteúdo verbal parece menos ansioso do que o corpo sugere. Vale observar se a inquietação aparece como urgência física, pouco ligada a pensamentos específicos, e se coincide temporalmente com início, retomada irregular ou mudança recente no tratamento.

Sedação e ritmo: Pode surgir sonolência, lentificação, menor espontaneidade ou dificuldade de sustentar o fio associativo, sobretudo no começo do uso ou após adesão irregular. Na sessão, isso às vezes se parece com retraimento depressivo, exaustão por insônia prévia ou efeito de outras medicações sedativas, e a distinção depende de comparar com a baseline do paciente e com o horário em que ele costuma ficar mais rebaixado. Quando a presença fica mais opaca, vale discriminar se houve também redução de sofrimento e organização maior, ou apenas queda de vitalidade.

Organização do pensamento: Quando a medicação está ajudando, pode haver menos dispersão, menor pressão para falar, menos desconfiança e mais possibilidade de acompanhar a conversa sem se perder. Em parte dos casos, porém, uma fala mais curta ou menos carregada afetivamente pode ser lida como melhora quando há apenas contenção, cansaço ou empobrecimento subjetivo. O terapeuta ganha precisão ao comparar a qualidade do contato, a coerência narrativa e a capacidade de elaboração, em vez de tomar apenas a redução de intensidade como sinal inequívoco de estabilização.

Humor e ativação: Em pacientes com oscilação de humor, a sessão pode mostrar redução de irritabilidade e aceleração, mas também pode emergir um rebaixamento pouco elaborado, com menos energia e menos acesso afetivo. Eventos de vida, privação de sono e uso irregular podem produzir oscilações que parecem mudança medicamentosa. A leitura clínica fica mais segura quando se observa se a energia caiu junto com a impulsividade e a desorganização, ou se houve apenas apagamento com sofrimento ainda presente.

Adesão silenciosa: A ziprasidona pode ser abandonada ou usada de modo irregular quando o paciente sente desconforto corporal, sonolência, sensação de estar 'travado' ou quando melhora parcialmente e conclui que não precisa mais. Na terapia, isso costuma aparecer indiretamente: piora súbita após período melhor, narrativa vaga sobre rotina, oscilação entre sessões muito diferentes ou dificuldade em explicar mudanças recentes. Em vez de presumir recaída ou resistência, vale explorar com cuidado a regularidade do uso e o que o paciente tem feito diante dos efeitos percebidos.

Sinais físicos relevantes: Embora o foco da sessão não seja exame físico, às vezes aparecem palpitações, tontura, sensação de desmaio iminente ou mal-estar corporal inespecífico que o paciente associa pouco ao tratamento. Esses sinais podem ser confundidos com crise de ansiedade, hipervigilância somática ou exaustão, especialmente em pacientes já ansiosos. Quando surgem junto de fraqueza, instabilidade ao levantar ou mal-estar novo e persistente, convém registrar o contexto e considerar comunicação mais célere com o médico assistente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A ziprasidona é um antipsicótico usado sobretudo em quadros psicóticos e em fases de humor com agitação ou aceleração, às vezes em manutenção. No consultório, as primeiras 1 a 3 semanas costumam concentrar mudanças mais visíveis de tolerabilidade e ritmo psíquico; ao longo de 2 a 6 semanas pode ficar mais claro se há redução de desorganização, irritabilidade, ideias persecutórias ou aceleração. O ponto central para o terapeuta é distinguir melhora do quadro de base de lentificação, inquietação corporal, sonolência ou embotamento que podem alterar a presença do paciente na sessão e afetar adesão silenciosa.

Perguntas úteis

- "Quando essa inquietação aparece, ela vem junto de pensamentos ansiosos ou parece mais um desconforto no corpo que pede movimento sem um motivo claro? , Você sente que está mais calmo de um jeito que ajuda a pensar e se organizar, ou mais apagado e distante do que sente? , Essa sonolência ou lentidão acontece o dia todo ou em períodos mais previsíveis, e o que muda na sua capacidade de conversar, trabalhar ou se concentrar? , Nas últimas semanas, a melhora veio com mais clareza e contato com a realidade, ou com menos intensidade emocional mas ainda com confusão, medo ou sofrimento por dentro? , Quando houve essa piora repentina, o que estava acontecendo na sua rotina: noites mal dormidas, estresse recente, uso irregular da medicação ou algo diferente no corpo? , Você percebe alguma relação entre tomar a medicação de forma irregular e voltar a ficar mais desconfiado, acelerado, irritado ou desorganizado?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve inquietação corporal persistente
- difícil de suportar
- que interfere em permanecer sentado
- dormir ou seguir a rotina
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar ansiedade do quadro de um efeito que compromete adesão
- Quando a sessão passa a mostrar sedação importante
- lentificação marcante ou empobrecimento da participação que não se explica bem pela evolução do quadro
- pode valer contato com o médico para revisar a leitura clínica e o impacto funcional
- Quando há piora após melhora inicial e surgem indícios de uso irregular
- abandono silencioso ou retomadas intermitentes
- pode ser útil comunicar o médico assistente para coordenar a compreensão do que está acontecendo
- Quando aparecem palpitações
- tontura recorrente
- sensação de quase desmaio ou mal-estar físico novo associado ao período de uso
- pode valer alinhamento mais rápido com o psiquiatra pela necessidade de avaliação médica

Amarelo: alinhar em breve

- Quando
- após algumas semanas
- persistem desorganização importante
- ideias persecutórias
- aceleração ou agitação sem sinal claro de ganho clínico
- pode valer comunicar o médico para situar ausência de resposta percebida na terapia

Vermelho: tratar como urgência

- Palpitações intensas
- tontura importante
- sensação de desmaio iminente ou colapso durante a sessão.: Interromper o trabalho clínico
- buscar avaliação médica no mesmo dia e acionar suporte imediato se houver risco de queda ou piora clínica
- Aparecimento de forte agitação
- redução importante da necessidade de sono
- fala muito acelerada
- grandiosidade ou desorganização crescente em paciente vulnerável a oscilação de humor.: Contatar o psiquiatra no mesmo dia e avaliar necessidade de rede de apoio e manejo de crise conforme o risco
- Ideias de morte ou autoagressão emergem junto de piora abrupta
- intensa inquietação ou sensação de desespero difícil de conter.: Fazer avaliação de risco imediata
- acionar psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhar para emergência quando necessário

Frase clínica

Na terapia, o foco com ziprasidona é separar contenção útil do quadro de inquietação, sedação ou apagamento que podem minar adesão e leitura clínica.

064 CLOZAPINA

Substância: Clozapina.

Nomes Comerciais: Clozapina, Pinazan, Okótico, Leponex

Uso comum

- A clozapina é um antipsicótico usado sobretudo em quadros psicóticos persistentes, refratários ou com risco importante de desorganização e recaída, muitas vezes após trajetórias longas de tratamento. No consultório, as primeiras semanas costumam exigir atenção maior para sedação, lentificação, tontura, aumento do sono e mudanças no padrão de presença em sessão; ao longo de semanas a poucos meses, também podem ganhar relevo ganho de peso, apetite, salivação excessiva e impacto na adesão. O ponto central para o terapeuta é diferenciar estabilização clínica de embotamento, sedação ou abandono silencioso por efeitos que o paciente pode sentir como constrangedores ou incapacitantes.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, dificuldade de sustentar atenção e redução da iniciativa podem aparecer de modo marcante, especialmente no início ou após mudanças recentes percebidas pelo paciente no tratamento. Na sessão, isso pode se confundir com retraimento depressivo, empobrecimento negativo do quadro psicótico ou simples exaustão por rotina desorganizada. Vale observar se a lentificação varia conforme o horário da sessão, se houve mudança abrupta em relação à baseline e se o paciente segue conseguindo se engajar minimamente quando mais desperto.

Salivação e constrangimento: Salivação excessiva, sobretudo à noite ou ao falar por mais tempo, pode surgir como fonte de vergonha, evitação social e recuo no vínculo, às vezes sem ser trazida espontaneamente. Em sessão, o terapeuta pode notar enxugar a boca, engolir repetidamente, desconforto corporal ou menor disponibilidade para falar. Isso pode ser lido apressadamente como ansiedade social, inibição defensiva ou piora negativa, quando parte do afastamento pode estar ligada a constrangimento físico e medo de exposição.

Apetite e peso: Aumento do apetite, ganho de peso e sensação de perda de controle alimentar podem alterar autoestima, rotina e disposição para sair de casa. O impacto subjetivo às vezes aparece antes de mudanças corporais muito visíveis, com vergonha, autocrítica ou abandono de atividades. Também aqui é fácil confundir com comer emocional, piora depressiva, sedentarismo prévio ou efeitos de outras medicações; por isso, interessa mapear a sequência temporal entre mudança corporal percebida, humor e retraimento social.

Cognição e organização: Alguns pacientes chegam mais concretos, lentificados ou com menor fluidez associativa, enquanto outros mostram melhora da desorganização e maior contato com a realidade, ainda que com custo subjetivo de se sentirem mais pesados ou menos ágeis. O desafio clínico é não tomar toda redução de intensidade psicótica como melhora global, nem toda dificuldade cognitiva como progressão do transtorno. Comparar com o padrão anterior de sessão, com o funcionamento fora do consultório e com a regularidade do uso ajuda a discriminar estabilização útil de um estado excessivamente amortecido.

Adesão silenciosa: A clozapina frequentemente convoca ambivalência: o paciente pode reconhecer benefício em reduzir vozes, paranoia ou desorganização e, ao mesmo tempo, sentir-se limitado por sono, peso, salivação ou exigências do tratamento. Na prática, isso favorece uso irregular, omissões não verbalizadas e narrativas vagas de 'estar tomando mais ou menos'. Quando a sessão oscila muito entre dias de maior clareza e dias de piora, vale considerar não só evolução do quadro e estressores externos, mas também adesão inconsistente motivada por efeitos difíceis de admitir.

Sinais físicos relevantes: Constipação importante, tontura ao levantar, mal-estar inespecífico e sensação de estar 'estranho no corpo' podem aparecer no relato e influenciar humor, irritabilidade e disponibilidade psíquica. Em sessão, o paciente pode parecer desconfortável, inquieto de modo não ansioso, ou excessivamente preocupado com o corpo sem conseguir nomear bem o que sente. Nem tudo será atribuível ao medicamento, mas a combinação entre piora física recente, redução do funcionamento e confusão mental merece leitura mais cautelosa e eventual comunicação médica."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, dificuldade de sustentar atenção e redução da iniciativa podem aparecer de modo marcante, especialmente no início ou após mudanças recentes percebidas pelo paciente no tratamento. Na sessão, isso pode se confundir com retraimento depressivo, empobrecimento negativo do quadro psicótico ou simples exaustão por rotina desorganizada. Vale observar se a lentificação varia conforme o horário da sessão, se houve mudança abrupta em relação à baseline e se o paciente segue conseguindo se engajar minimamente quando mais desperto.

Salivação e constrangimento: Salivação excessiva, sobretudo à noite ou ao falar por mais tempo, pode surgir como fonte de vergonha, evitação social e recuo no vínculo, às vezes sem ser trazida espontaneamente. Em sessão, o terapeuta pode notar enxugar a boca, engolir repetidamente, desconforto corporal ou menor disponibilidade para falar. Isso pode ser lido apressadamente como ansiedade social, inibição defensiva ou piora negativa, quando parte do afastamento pode estar ligada a constrangimento físico e medo de exposição.

Apetite e peso: Aumento do apetite, ganho de peso e sensação de perda de controle alimentar podem alterar autoestima, rotina e disposição para sair de casa. O impacto subjetivo às vezes aparece antes de mudanças corporais muito visíveis, com vergonha, autocrítica ou abandono de atividades. Também aqui é fácil confundir com comer emocional, piora depressiva, sedentarismo prévio ou efeitos de outras medicações; por isso, interessa mapear a sequência temporal entre mudança corporal percebida, humor e retraimento social.

Cognição e organização: Alguns pacientes chegam mais concretos, lentificados ou com menor fluidez associativa, enquanto outros mostram melhora da desorganização e maior contato com a realidade, ainda que com custo subjetivo de se sentirem mais pesados ou menos ágeis. O desafio clínico é não tomar toda redução de intensidade psicótica como melhora global, nem toda dificuldade cognitiva como progressão do transtorno. Comparar com o padrão anterior de sessão, com o funcionamento fora do consultório e com a regularidade do uso ajuda a discriminar estabilização útil de um estado excessivamente amortecido.

Adesão silenciosa: A clozapina frequentemente convoca ambivalência: o paciente pode reconhecer benefício em reduzir vozes, paranoia ou desorganização e, ao mesmo tempo, sentir-se limitado por sono, peso, salivação ou exigências do tratamento. Na prática, isso favorece uso irregular, omissões não verbalizadas e narrativas vagas de 'estar tomando mais ou menos'. Quando a sessão oscila muito entre dias de maior clareza e dias de piora, vale considerar não só evolução do quadro e estressores externos, mas também adesão inconsistente motivada por efeitos difíceis de admitir.

Sinais físicos relevantes: Constipação importante, tontura ao levantar, mal-estar inespecífico e sensação de estar 'estranho no corpo' podem aparecer no relato e influenciar humor, irritabilidade e disponibilidade psíquica. Em sessão, o paciente pode parecer desconfortável, inquieto de modo não ansioso, ou excessivamente preocupado com o corpo sem conseguir nomear bem o que sente. Nem tudo será atribuível ao medicamento, mas a combinação entre piora física recente, redução do funcionamento e confusão mental merece leitura mais cautelosa e eventual comunicação médica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A clozapina é um antipsicótico usado sobretudo em quadros psicóticos persistentes, refratários ou com risco importante de desorganização e recaída, muitas vezes após trajetórias longas de tratamento. No consultório, as primeiras semanas costumam exigir atenção maior para sedação, lentificação, tontura, aumento do sono e mudanças no padrão de presença em sessão; ao longo de semanas a poucos meses, também podem ganhar relevo ganho de peso, apetite, salivação excessiva e impacto na adesão. O ponto central para o terapeuta é diferenciar estabilização clínica de embotamento, sedação ou abandono silencioso por efeitos que o paciente pode sentir como constrangedores ou incapacitantes.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais apagado ou sonolento, isso parece um cansaço do dia, uma tristeza parecida com fases depressivas suas, ou algo que começou junto com o tratamento e muda conforme o horário? , Essa sensação de estar mais 'plano' vem com menos sofrimento e mais organização, ou com a impressão de que você perdeu acesso às emoções e ficou distante de si mesmo? , Nos dias em que você evita sair ou falar menos, o que pesa mais: medo das pessoas, falta de energia, vergonha do corpo ou incômodo físico como salivação e sono? , Quando sua semana oscila entre dias muito melhores e dias de piora, isso acompanha acontecimentos da rotina ou coincide com dias em que tomar o remédio fica mais difícil? , Essa dificuldade de pensar e se organizar parece a mesma confusão de antes, ou é diferente, como se você estivesse mais presente porém mais lento? , Quando você fala que está 'aguentando mal' o tratamento, o que mais faz você pensar em pular ou atrasar tomadas: sono, peso, salivação, mal-estar físico ou outra coisa?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- dormir na sessão ou ficar muito lentificado a ponto de comprometer o trabalho terapêutico e o funcionamento diário
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar tolerabilidade e adesão
- Quando surgem omissões frequentes
- uso irregular admitido ou forte ambivalência por efeitos como salivação
- ganho de peso e sedação
- pode valer comunicar o médico assistente porque isso aumenta risco de abandono silencioso e descompensação
- Quando a família ou o próprio paciente descrevem retorno de vozes
- paranoia
- desorganização ou agitação após período de maior estabilidade
- especialmente junto de adesão incerta
- pode valer contato para discriminar recaída de uso inconsistente
- Quando aparecem constipação importante

Amarelo: alinhar em breve

- tontura recorrente
- mal-estar físico relevante ou confusão nova junto de piora do funcionamento
- pode valer alinhar com o psiquiatra para avaliação clínica mais próxima
- Quando o paciente relata benefício parcial
- mas custo subjetivo alto que ameaça continuidade do tratamento e o vínculo com o cuidado
- pode valer comunicação para que a equipe tenha a mesma leitura do risco de abandono

Vermelho: tratar como urgência

- Febre
- dor de garganta importante
- prostração incomum ou aparência de adoecimento agudo em paciente usando clozapina.: Interromper o foco psicoterápico e encaminhar para avaliação médica no mesmo dia
- acionando rede de apoio se necessário
- Confusão acentuada
- rebaixamento importante do nível de alerta
- desorientação ou piora abrupta do estado mental acompanhada de mal-estar físico.: Acionar avaliação médica imediata e
- se houver risco clínico ou incapacidade de locomoção segura
- recorrer à emergência e à rede de apoio
- Ideação suicida com intenção
- plano ou perda importante de controle
- especialmente em contexto de piora psicótica
- abandono do tratamento ou desorganização crescente.: Fazer manejo de crise no mesmo dia
- acionar psiquiatra
- rede de apoio e serviços de urgência conforme o risco observado

Frase clínica

Na terapia, o foco com clozapina é distinguir estabilização útil de sedação, embotamento e abandono silencioso por efeitos difíceis de sustentar.

065 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA

Substância: Hemifumarato de Quetiapina.

Nomes Comerciais: Hemifumarato de Quetiapina, Quet Xr, Quet, Quepsia Lp, Neotiapim, Quetipin, Quetipin Lp, Quetipin So, Atip, Atip Xr, Tracox, Quetros, Mensyva, Kitapen, Queropax, Seroquel

Uso comum

- A quetiapina é um antipsicótico atípico que costuma aparecer no consultório em pacientes com transtorno bipolar, quadros psicóticos, depressão resistente e, em alguns casos, como adjuvante para sono ou ansiedade. Nas primeiras semanas, o que mais tende a mudar na sessão é o nível de sedação, a lentificação e a organização do pensamento; em parte dos pacientes, o efeito subjetivo sobre agitação e insônia surge cedo, enquanto a estabilização mais ampla do humor e da desorganização pode levar algumas semanas. O ponto central para o terapeuta é diferenciar melhora clínica de apagamento excessivo, além de observar adesão irregular, abandono silencioso por desconforto e sinais de virada de humor ou piora importante do funcionamento.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, dificuldade de sustentar atenção e menor espontaneidade podem aparecer logo no início ou após mudanças recentes no uso. Na sessão, isso pode se confundir com retraimento depressivo, exaustão por privação de sono ou efeito de outras medicações sedativas. Vale comparar com a linha de base: se o paciente está menos sofrido, mas também menos acessível afetivamente e mais arrastado do que o habitual, a leitura clínica pede cautela.

Sono e ritmo: Muitos pacientes chegam relatando que passaram a dormir mais rápido ou por mais horas, às vezes com sensação de sono pouco reparador ao despertar. Isso pode representar redução de ativação noturna, mas também pode vir acompanhado de dificuldade para acordar, atrasos, cochilos diurnos e queda de ritmo que interferem no trabalho terapêutico. Quando o padrão oscila muito entre dias, convém considerar adesão irregular, uso concomitante de álcool ou hipnóticos e mudanças recentes na rotina.

Humor e reatividade: A sessão pode mostrar menos irritabilidade, menor urgência interna e mais capacidade de pausa, o que às vezes é vivido como alívio e, em outras, como embotamento. Em pacientes bipolares, a redução da agitação pode mascarar uma oscilação de humor ainda em curso, especialmente se persistem impulsividade, grandiosidade ou redução importante da necessidade de sono. Também é útil não atribuir toda mudança ao medicamento quando houve eventos de vida relevantes ou remissão espontânea parcial do episódio.

Cognição e organização: Alguns pacientes parecem mais organizados e menos dispersos, enquanto outros ficam mais lentificados, com dificuldade de encontrar palavras, acompanhar associações ou elaborar afetos com a mesma fluidez. Na prática da sessão, isso pode ser confundido com melhora da aceleração mental, piora depressiva, uso de substâncias ou cansaço acumulado. A discriminação depende de observar se houve ganho de coerência com preservação de presença subjetiva, ou se a sessão ficou empobrecida e pouco responsiva.

Apetite e peso: Aumento de fome, busca mais frequente por comida e incômodo com ganho de peso podem surgir relativamente cedo e afetar autoestima, imagem corporal e adesão. Às vezes o paciente não nomeia isso espontaneamente, mas aparecem vergonha, evitação sexual, irritação com o próprio corpo ou abandono de atividades. Como mudanças de apetite também acompanham melhora de humor, ansiedade ou rotina, vale explorar o encadeamento temporal sem concluir causalidade de imediato.

Adesão e interrupção: A quetiapina pode ser abandonada silenciosamente quando o paciente se sente excessivamente sedado, ganha peso ou passa a temer ficar apagado. Na sessão, isso aparece como uso irregular, retomadas por conta própria, oscilação entre noites muito dormidas e noites em claro, ou narrativa vaga sobre como tem tomado a medicação. Nesses casos, a instabilidade clínica pode refletir tanto o quadro de base quanto um padrão de adesão inconsistente, e essa distinção muda bastante a leitura do processo terapêutico."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, dificuldade de sustentar atenção e menor espontaneidade podem aparecer logo no início ou após mudanças recentes no uso. Na sessão, isso pode se confundir com retraimento depressivo, exaustão por privação de sono ou efeito de outras medicações sedativas. Vale comparar com a linha de base: se o paciente está menos sofrido, mas também menos acessível afetivamente e mais arrastado do que o habitual, a leitura clínica pede cautela.

Sono e ritmo: Muitos pacientes chegam relatando que passaram a dormir mais rápido ou por mais horas, às vezes com sensação de sono pouco reparador ao despertar. Isso pode representar redução de ativação noturna, mas também pode vir acompanhado de dificuldade para acordar, atrasos, cochilos diurnos e queda de ritmo que interferem no trabalho terapêutico. Quando o padrão oscila muito entre dias, convém considerar adesão irregular, uso concomitante de álcool ou hipnóticos e mudanças recentes na rotina.

Humor e reatividade: A sessão pode mostrar menos irritabilidade, menor urgência interna e mais capacidade de pausa, o que às vezes é vivido como alívio e, em outras, como embotamento. Em pacientes bipolares, a redução da agitação pode mascarar uma oscilação de humor ainda em curso, especialmente se persistem impulsividade, grandiosidade ou redução importante da necessidade de sono. Também é útil não atribuir toda mudança ao medicamento quando houve eventos de vida relevantes ou remissão espontânea parcial do episódio.

Cognição e organização: Alguns pacientes parecem mais organizados e menos dispersos, enquanto outros ficam mais lentificados, com dificuldade de encontrar palavras, acompanhar associações ou elaborar afetos com a mesma fluidez. Na prática da sessão, isso pode ser confundido com melhora da aceleração mental, piora depressiva, uso de substâncias ou cansaço acumulado. A discriminação depende de observar se houve ganho de coerência com preservação de presença subjetiva, ou se a sessão ficou empobrecida e pouco responsiva.

Apetite e peso: Aumento de fome, busca mais frequente por comida e incômodo com ganho de peso podem surgir relativamente cedo e afetar autoestima, imagem corporal e adesão. Às vezes o paciente não nomeia isso espontaneamente, mas aparecem vergonha, evitação sexual, irritação com o próprio corpo ou abandono de atividades. Como mudanças de apetite também acompanham melhora de humor, ansiedade ou rotina, vale explorar o encadeamento temporal sem concluir causalidade de imediato.

Adesão e interrupção: A quetiapina pode ser abandonada silenciosamente quando o paciente se sente excessivamente sedado, ganha peso ou passa a temer ficar "apagado". Na sessão, isso aparece como uso irregular, retomadas por conta própria, oscilação entre noites muito dormidas e noites em claro, ou narrativa vaga sobre como tem tomado a medicação. Nesses casos, a instabilidade clínica pode refletir tanto o quadro de base quanto um padrão de adesão inconsistente, e essa distinção muda bastante a leitura do processo terapêutico.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A quetiapina é um antipsicótico atípico que costuma aparecer no consultório em pacientes com transtorno bipolar, quadros psicóticos, depressão resistente e, em alguns casos, como adjuvante para sono ou ansiedade. Nas primeiras semanas, o que mais tende a mudar na sessão é o nível de sedação, a lentificação e a organização do pensamento; em parte dos pacientes, o efeito subjetivo sobre agitação e insônia surge cedo, enquanto a estabilização mais ampla do humor e da desorganização pode levar algumas semanas. O ponto central para o terapeuta é diferenciar melhora clínica de apagamento excessivo, além de observar adesão irregular, abandono silencioso por desconforto e sinais de virada de humor ou piora importante do funcionamento.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso vem junto de alívio da agitação e do sofrimento, ou parece mais um apagamento que atrapalha você a pensar e se envolver? , Nos dias em que dorme melhor, você acorda mais estável e funcional, ou acorda pesado, atrasado e com dificuldade de entrar no dia? , Essa redução da intensidade emocional parece uma melhora com mais espaço para refletir, ou uma sensação de estar distante de si e das pessoas? , Quando seu humor melhora, isso acontece junto com mais organização e limite, ou junto com menos sono, mais impulsos e sensação de estar acelerado demais? , As oscilações que você percebe ao longo da semana combinam com algo da sua rotina e dos acontecimentos, ou aparecem mais em dias em que o uso da medicação sai do padrão? , O incômodo com corpo, fome ou peso mudou sua vontade de continuar o tratamento ou sua forma de se relacionar afetivamente?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega persistentemente muito sedado
- lentificado ou com prejuízo funcional claro nas atividades diurnas
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisar o impacto clínico dessa mudança
- Quando surgem sinais de possível elevação patológica do humor
- como redução importante da necessidade de sono
- impulsividade e expansividade fora da linha de base
- pode valer comunicar o médico para reavaliação do quadro
- Quando o paciente relata uso irregular
- interrupções por conta própria ou abandono silencioso por desconforto com sono
- peso ou sensação de apagamento
- pode valer alinhar com o psiquiatra para evitar leitura equivocada de recaída ou resistência
- Quando há ganho de peso ou aumento de apetite com sofrimento relevante
- vergonha corporal ou risco de abandono do tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente pelo impacto na adesão e no funcionamento
- Quando
- após algumas semanas

Amarelo: alinhar em breve

- não se observa melhora clínica minimamente consistente e a sessão segue marcada por desorganização
- insônia ou sofrimento intenso
- pode valer alinhar com o psiquiatra para atualização da avaliação

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecimento de fala muito acelerada
- redução acentuada da necessidade de sono
- impulsividade incomum
- grandiosidade ou comportamento claramente fora da linha de base.: Tratar como urgência do dia
- acionar o psiquiatra e ampliar rede de apoio; se houver risco comportamental importante
- considerar avaliação de emergência
- Ideação suicida com intensificação recente
- maior impulsividade
- desesperança marcada ou sensação de perda de controle
- sobretudo no contexto de oscilação de humor.: Fazer avaliação de risco na sessão e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Paciente chega muito confuso
- excessivamente sonolento
- com fala desconexa ou rebaixamento importante do nível de alerta
- sem conseguir sustentar a sessão com segurança.: Interromper o enquadre habitual
- buscar suporte imediato de familiar ou rede e encaminhar para avaliação médica urgente

Frase clínica

Na terapia, o foco com quetiapina é distinguir contenção clínica de sedação excessiva e acompanhar adesão, ritmo de sono e possíveis oscilações de humor.

066 OLANZAPINA

Substância: Olanzapina.

Nomes Comerciais: Olanzapina, Zap, Zopix, Crisapina, Olanexyn, Axonium, Olanzys, Zyprexa, Onaz

Uso comum

- A olanzapina é um antipsicótico que costuma aparecer no consultório em quadros psicóticos, transtorno bipolar e, às vezes, como adjuvante em depressão resistente ou em fases de grande desorganização, agitação e insônia. Nas primeiras semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto sedação, lentificação, aumento de apetite e mudanças no acesso afetivo; ao longo de semanas a poucos meses, podem ganhar relevo ganho de peso, retraimento social, menor iniciativa e dificuldades de adesão. O ponto central na sessão é diferenciar contenção útil do quadro de um apagamento excessivo da experiência, além de observar se a melhora aparente vem com mais organização psíquica ou apenas com menor expressão.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, maior latência de resposta e dificuldade de sustentar atenção podem aparecer logo no início ou após retomadas irregulares. Na sessão, isso pode se confundir com piora depressiva, exaustão por insônia prévia ou simples alívio depois de um período de agitação intensa. Vale comparar com a linha de base recente: se o paciente está mais organizado, porém excessivamente amortecido, a leitura clínica muda em relação a uma melhora acompanhada de presença psíquica preservada.

Apetite e peso: Aumento importante de fome, comer mais à noite, sensação de perda de freio diante da comida e incômodo com o corpo são temas frequentes ao longo das primeiras semanas e meses. Isso pode repercutir em autoestima, sexualidade, evitação social e adesão silenciosamente frágil, sobretudo quando o paciente sente que 'melhorou, mas ficou outro no corpo'. Eventos de vida, redução da atividade física, recuperação de um episódio agudo e outras medicações também podem participar dessa mudança, então convém observar o ritmo em que isso surgiu e o quanto passou a organizar a rotina e o humor.

Acesso afetivo: Em parte dos pacientes, a sessão ganha menos intensidade emocional: há menos reatividade, menos urgência interna e mais capacidade de permanecer no enquadre, o que pode ser terapêutico. Em outros, surge um embotamento que empobrece a elaboração, reduz espontaneidade e deixa o relato excessivamente plano, sem que isso corresponda a melhora subjetiva consistente. A distinção clínica costuma aparecer quando se investiga se houve alívio do sofrimento com manutenção de vínculo e interesse, ou se o paciente se percebe apenas mais desligado de si e dos outros.

Organização do pensamento: Quando a olanzapina está associada a melhora do quadro de base, o terapeuta pode notar discurso menos fragmentado, menor desconfiança, menos aceleração e mais continuidade narrativa ao longo de dias a semanas. Ainda assim, a sessão pode trazer oscilação entre maior organização e momentos de confusão, especialmente se houver uso irregular, privação de sono, substâncias ou evolução do próprio transtorno. O ponto não é tomar qualquer redução de intensidade como melhora global, mas observar se houve ganho real de contato com a realidade compartilhada e de capacidade reflexiva.

Adesão silenciosa: A olanzapina frequentemente coloca o paciente diante de um dilema subjetivo: sentir-se menos tomado pelo quadro, mas às custas de sono, peso, lentificação ou sensação de estar 'apagado'. Nessa situação, faltas, esquecimentos, uso intermitente e interrupções por conta própria podem surgir sem anúncio prévio, e a sessão às vezes capta isso antes da consulta médica. Mudanças abruptas no padrão de presença, reaparecimento de agitação, insônia ou estranheza do pensamento podem refletir tanto evolução do quadro quanto adesão irregular, e essa distinção tem alto valor clínico.

Agitação paradoxal: Embora o mais comum seja contenção e redução de agitação, alguns pacientes chegam inquietos, incapazes de ficar confortáveis no corpo, levantando-se muito ou descrevendo um mal-estar motor difícil de nomear. Na sessão, isso pode ser confundido com ansiedade habitual, tensão por conflito atual ou ativação de um episódio de humor. A discriminação depende de notar se a inquietação é mais corporal do que psíquica, se piorou após mudanças recentes no uso e se vem acompanhada de melhora, piora ou nenhuma

mudança na qualidade dos pensamentos."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, maior latência de resposta e dificuldade de sustentar atenção podem aparecer logo no início ou após retomadas irregulares. Na sessão, isso pode se confundir com piora depressiva, exaustão por insônia prévia ou simples alívio depois de um período de agitação intensa. Vale comparar com a linha de base recente: se o paciente está mais organizado, porém excessivamente amortecido, a leitura clínica muda em relação a uma melhora acompanhada de presença psíquica preservada.

Apetite e peso: Aumento importante de fome, comer mais à noite, sensação de perda de freio diante da comida e incômodo com o corpo são temas frequentes ao longo das primeiras semanas e meses. Isso pode repercutir em autoestima, sexualidade, evitação social e adesão silenciosamente frágil, sobretudo quando o paciente sente que 'melhorou, mas ficou outro no corpo'. Eventos de vida, redução da atividade física, recuperação de um episódio agudo e outras medicações também podem participar dessa mudança, então convém observar o ritmo em que isso surgiu e o quanto passou a organizar a rotina e o humor.

Acesso afetivo: Em parte dos pacientes, a sessão ganha menos intensidade emocional: há menos reatividade, menos urgência interna e mais capacidade de permanecer no enquadre, o que pode ser terapêutico. Em outros, surge um embotamento que empobrece a elaboração, reduz espontaneidade e deixa o relato excessivamente plano, sem que isso corresponda a melhora subjetiva consistente. A distinção clínica costuma aparecer quando se investiga se houve alívio do sofrimento com manutenção de vínculo e interesse, ou se o paciente se percebe apenas mais desligado de si e dos outros.

Organização do pensamento: Quando a olanzapina está associada a melhora do quadro de base, o terapeuta pode notar discurso menos fragmentado, menor desconfiança, menos aceleração e mais continuidade narrativa ao longo de dias a semanas. Ainda assim, a sessão pode trazer oscilação entre maior organização e momentos de confusão, especialmente se houver uso irregular, privação de sono, substâncias ou evolução do próprio transtorno. O ponto não é tomar qualquer redução de intensidade como melhora global, mas observar se houve ganho real de contato com a realidade compartilhada e de capacidade reflexiva.

Adesão silenciosa: A olanzapina frequentemente coloca o paciente diante de um dilema subjetivo: sentir-se menos tomado pelo quadro, mas às custas de sono, peso, lentificação ou sensação de estar 'apagado'. Nessa situação, faltas, esquecimentos, uso intermitente e interrupções por conta própria podem surgir sem anúncio prévio, e a sessão às vezes capta isso antes da consulta médica. Mudanças abruptas no padrão de presença, reaparecimento de agitação, insônia ou estranheza do pensamento podem refletir tanto evolução do quadro quanto adesão irregular, e essa distinção tem alto valor clínico.

Agitação paradoxal: Embora o mais comum seja contenção e redução de agitação, alguns pacientes chegam inquietos, incapazes de ficar confortáveis no corpo, levantando-se muito ou descrevendo um mal-estar motor difícil de nomear. Na sessão, isso pode ser confundido com ansiedade habitual, tensão por conflito atual ou ativação de um episódio de humor. A discriminação depende de notar se a inquietação é mais corporal do que psíquica, se piorou após mudanças recentes no uso e se vem acompanhada de melhora, piora ou nenhuma

mudança na qualidade dos pensamentos.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A olanzapina é um antipsicótico que costuma aparecer no consultório em quadros psicóticos, transtorno bipolar e, às vezes, como adjuvante em depressão resistente ou em fases de grande desorganização, agitação e insônia. Nas primeiras semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto sedação, lentificação, aumento de apetite e mudanças no acesso afetivo; ao longo de semanas a poucos meses, podem ganhar relevo ganho de peso, retraimento social, menor iniciativa e dificuldades de adesão. O ponto central na sessão é diferenciar contenção útil do quadro de um apagamento excessivo da experiência, além de observar se a melhora aparente vem com mais organização psíquica ou apenas com menor expressão.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais 'lento' ou sonolento, isso vem junto de alívio da agitação e mais clareza, ou parece mais um apagamento que atrapalha pensar e estar aqui? , Essa diminuição da intensidade emocional tem sido vivida como paz e maior controle, ou como distanciamento de si, das pessoas e do que antes importava? , A fome e a mudança no corpo apareceram de forma gradual junto com outras mudanças da rotina, ou você percebe um antes e depois mais nítido desde que começou a medicação? , Quando a inquietação aparece, ela parece vir de pensamentos acelerados e preocupação, ou é mais uma sensação física de não conseguir ficar parado mesmo sem um motivo claro? , Nas semanas em que você pareceu piorar ou ficar mais confuso, houve também mudança no sono, uso irregular da medicação ou alguma interrupção que você não tinha comentado? , O que melhorou primeiro: o sofrimento interno, a organização dos pensamentos ou apenas o fato de você estar menos reativo por fora?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente mostra sedação persistente
- lentificação marcante ou apagamento afetivo que começam a comprometer trabalho terapêutico
- funcionamento ou adesão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar o impacto clínico observado
- Quando surgem aumento importante de apetite
- ganho de peso percebido pelo paciente e sofrimento corporal que passam a motivar evitação social ou desejo de abandonar o tratamento em silêncio
- pode valer comunicar o médico assistente pela repercussão na continuidade do cuidado
- Quando há reaparecimento de insônia
- desorganização do pensamento
- desconfiança
- agitação ou aceleração após uso irregular
- esquecimentos frequentes ou interrupção por conta própria
- pode valer contato com o psiquiatra para contextualizar a oscilação clínica

Amarelo: alinhar em breve

- Quando a sessão sugere inquietação corporal nova ou muito intensificada
- difícil de diferenciar de ansiedade habitual
- pode valer alinhar com o médico assistente para registrar temporalidade e impacto funcional
- Quando
- após algumas semanas
- não se observa ganho de organização psíquica
- redução de agitação ou melhora subjetiva minimamente consistente
- apesar de uso aparentemente regular
- pode valer comunicar o psiquiatra para compartilhar a ausência de mudança percebida no setting

Vermelho: tratar como urgência

- Surge piora rápida com intensa agitação
- confusão
- fala muito desconexa
- medo extremo ou comportamento claramente desorganizado durante a sessão.: Priorizar contenção e avaliação de segurança
- acionar o psiquiatra no mesmo dia e mobilizar rede de apoio ou emergência quando necessário
- O paciente relata ideias de morte ou suicídio com intenção
- plano ou perda importante de controle
- especialmente em contexto de piora recente do quadro.: Fazer manejo imediato de risco
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- recorrendo à emergência se necessário
- Há rigidez intensa
- rebaixamento importante do contato
- sudorese marcante
- tremor ou aparência de adoecimento agudo associada a mudança comportamental relevante.: Interromper o foco interpretativo
- buscar avaliação médica urgente no mesmo dia e acionar emergência se houver comprometimento importante do estado geral

Frase clínica

Na terapia, o foco com olanzapina é distinguir organização psíquica útil de sedação e embotamento que empobrecem presença, vínculo e adesão.

067 PALIPERIDONA

Substância: Paliperidona.

Nomes Comerciais: Invega

Uso comum

- Paliperidona é um antipsicótico usado sobretudo em quadros psicóticos, episódios com desorganização importante e, em alguns casos, manutenção de estabilidade após crises. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta costuma acompanhar mais de perto sedação, lentificação, inquietação corporal e mudanças no acesso afetivo; ao longo de 4 a 8 semanas, tende a ficar mais claro se houve redução de agitação, desconfiança ou desorganização sem custo subjetivo excessivo. Quando há formulação de longa ação, oscilações por adesão irregular podem aparecer menos como “esquecimento” e mais como mudança gradual do padrão da sessão. O ponto central é diferenciar contenção útil de embotamento, e melhora do quadro de base de efeitos que empobrecem presença, iniciativa ou vínculo.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e lentificação":** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter fala mais lenta, maior latência de resposta, sonolência visível ou redução da iniciativa associativa. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento no processo ou resistência, quando às vezes coincide temporalmente com o início do tratamento ou com mudança recente no padrão de uso. Também vale considerar privação de sono, uso de outras medicações sedativas e o próprio esgotamento pós-crise, que podem produzir uma apresentação semelhante.

Inquietação corporal: Alguns pacientes descrevem um desconforto difícil de nomear, com necessidade de se mexer, trocar de posição ou sensação de não conseguir ficar parado, mesmo quando dizem estar “ansiosos” apenas em parte. Na sessão, isso pode aparecer como balanço de pernas, levantar-se repetidamente, irritabilidade sem conteúdo claro ou dificuldade de sustentar silêncio e reflexão. O principal confundidor é a ansiedade habitual do paciente, mas a diferença costuma estar no predomínio corporal, na novidade do fenômeno e na menor ligação com pensamentos antecipatórios ou temas da sessão.

Embotamento afetivo: A melhora de delírios, agitação ou desorganização pode vir acompanhada de redução da expressividade, menor variação emocional e relato de estar “mais travado” ou “meio desligado”. O terapeuta pode observar menos espontaneidade, menor ressonância afetiva e empobrecimento do discurso, o que às vezes se confunde com retraimento defensivo, sintomas negativos do quadro de base ou efeito de um período recente de crise. A discriminação clínica depende de comparar com a linha de base prévia e perguntar se houve alívio subjetivo junto dessa contenção ou se o paciente sente perda de vitalidade e presença.

Cognição e elaboração: Pode surgir sensação de pensamento mais lento, dificuldade para organizar narrativas longas ou menor flexibilidade para associar temas, especialmente no início do acompanhamento medicamentoso ou após descompensações recentes. Na sessão, isso pode ser percebido como concretude maior, respostas curtas e dificuldade de sustentar elaboração simbólica, mas esse padrão também pode refletir remanescentes do episódio psicótico, baixa escolarização, ansiedade intensa ou fadiga. Mais útil do que supor causa é observar se a organização melhorou enquanto a velocidade caiu, ou se há empobrecimento global do funcionamento.

Adesão e continuidade: Com paliperidona, a adesão irregular nem sempre aparece como recusa aberta; às vezes surge como narrativa vaga sobre datas, minimização de faltas, oscilação gradual do contato com a realidade ou retorno de desconfiança e isolamento. Em formulações de longa ação, o paciente pode sentir que “está tudo igual” até que a sessão mostre mudança progressiva de presença, coerência ou reatividade. Também entram na conta efeitos incômodos que o paciente prefere não nomear por vergonha ou medo de perder autonomia, o que pode levar a abandono silencioso.

Sinais físicos visíveis: Alguns efeitos aparecem primeiro como observação do terapeuta: rigidez, face menos móvel, tremor fino, marcha mais endurecida ou queixa de corpo pesado. Esses sinais podem ser discretos e facilmente atribuídos a tensão, cansaço, traços de personalidade mais contidos ou ao próprio estado pós-crise. Quando surgem junto de piora funcional, sofrimento corporal ou mudança nítida em relação ao baseline, ganham valor clínico

como dado de comunicação ao médico assistente."

O que observar em sessão

- **Sedação e lentificação:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter fala mais lenta, maior latência de resposta, sonolência visível ou redução da iniciativa associativa. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento no processo ou resistência, quando às vezes coincide temporalmente com o início do tratamento ou com mudança recente no padrão de uso. Também vale considerar privação de sono, uso de outras medicações sedativas e o próprio esgotamento pós-crise, que podem produzir uma apresentação semelhante.

Inquietação corporal: Alguns pacientes descrevem um desconforto difícil de nomear, com necessidade de se mexer, trocar de posição ou sensação de não conseguir ficar parado, mesmo quando dizem estar “ansiosos” apenas em parte. Na sessão, isso pode aparecer como balanço de pernas, levantar-se repetidamente, irritabilidade sem conteúdo claro ou dificuldade de sustentar silêncio e reflexão. O principal confundidor é a ansiedade habitual do paciente, mas a diferença costuma estar no predomínio corporal, na novidade do fenômeno e na menor ligação com pensamentos antecipatórios ou temas da sessão.

Embotamento afetivo: A melhora de delírios, agitação ou desorganização pode vir acompanhada de redução da expressividade, menor variação emocional e relato de estar “mais travado” ou “meio desligado”. O terapeuta pode observar menos espontaneidade, menor ressonância afetiva e empobrecimento do discurso, o que às vezes se confunde com retraimento defensivo, sintomas negativos do quadro de base ou efeito de um período recente de crise. A discriminação clínica depende de comparar com a linha de base prévia e perguntar se houve alívio subjetivo junto dessa contenção ou se o paciente sente perda de vitalidade e presença.

Cognição e elaboração: Pode surgir sensação de pensamento mais lento, dificuldade para organizar narrativas longas ou menor flexibilidade para associar temas, especialmente no início do acompanhamento medicamentoso ou após descompensações recentes. Na sessão, isso pode ser percebido como concretude maior, respostas curtas e dificuldade de sustentar elaboração simbólica, mas esse padrão também pode refletir remanescentes do episódio psicótico, baixa escolarização, ansiedade intensa ou fadiga. Mais útil do que supor causa é observar se a organização melhorou enquanto a velocidade caiu, ou se há empobrecimento global do funcionamento.

Adesão e continuidade: Com paliperidona, a adesão irregular nem sempre aparece como recusa aberta; às vezes surge como narrativa vaga sobre datas, minimização de faltas, oscilação gradual do contato com a realidade ou retorno de desconfiança e isolamento. Em formulações de longa ação, o paciente pode sentir que “está tudo igual” até que a sessão mostre mudança progressiva de presença, coerência ou reatividade. Também entram na conta efeitos incômodos que o paciente prefere não nomear por vergonha ou medo de perder autonomia, o que pode levar a abandono silencioso.

Sinais físicos visíveis: Alguns efeitos aparecem primeiro como observação do terapeuta: rigidez, face menos móvel, tremor fino, marcha mais endurecida ou queixa de corpo pesado. Esses sinais podem ser discretos e facilmente atribuídos a tensão, cansaço, traços de personalidade mais contidos ou ao próprio estado pós-crise. Quando surgem junto de piora funcional, sofrimento corporal ou mudança nítida em relação ao baseline, ganham valor clínico

como dado de comunicação ao médico assistente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Paliperidona é um antipsicótico usado sobretudo em quadros psicóticos, episódios com desorganização importante e, em alguns casos, manutenção de estabilidade após crises. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta costuma acompanhar mais de perto sedação, lentificação, inquietação corporal e mudanças no acesso afetivo; ao longo de 4 a 8 semanas, tende a ficar mais claro se houve redução de agitação, desconfiança ou desorganização sem custo subjetivo excessivo. Quando há formulação de longa ação, oscilações por adesão irregular podem aparecer menos como “esquecimento” e mais como mudança gradual do padrão da sessão. O ponto central é diferenciar contenção útil de embotamento, e melhora do quadro de base de efeitos que empobrecem presença, iniciativa ou vínculo.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais travado ou mais lento, isso vem com sono e corpo pesado, ou com tristeza, culpa e perda de interesse pelas coisas? , Essa sensação de inquietação parece ligada a pensamentos e preocupações, ou é mais um incômodo no corpo que continua mesmo quando sua cabeça não está acelerada? , Desde que começou esse tratamento, você sente que ficou mais calmo de um jeito que ajuda a pensar melhor, ou mais apagado e distante de si mesmo? , Quando sua fala ou seu pensamento ficam mais difíceis de organizar, isso acontece o tempo todo ou piora em períodos específicos do dia ou em dias próximos de uso irregular? , O afastamento das pessoas tem vindo mais por desconfiança e medo do contato, ou por cansaço, pouca energia e menor vontade de se envolver? , Essas mudanças que você percebe começaram depois de uma fase de crise e exaustão, ou apareceram principalmente após o início ou a regularização da medicação?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- Lentificado ou com queda importante de participação na sessão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar contenção terapêutica de custo funcional excessivo
- Quando surge inquietação corporal nova
- difícil de sustentar na cadeira e pouco explicada pelos temas da sessão
- pode valer comunicar ao médico assistente para esclarecer se há efeito medicamentoso interferindo no manejo clínico
- Quando aparecem rigidez
- tremor
- marcha endurecida ou face muito menos expressiva em comparação com a linha de base
- pode valer contato com o psiquiatra para registrar a mudança observável e seu impacto funcional
- Quando o paciente minimiza faltas

Amarelo: alinhar em breve

- não consegue reconstruir a continuidade do uso ou apresenta oscilação gradual de desorganização e desconfiança
- pode valer alinhar com o médico para situar a hipótese de adesão irregular
- Quando
 - após 4 a 8 semanas
 - não se observa redução de agitação
 - desorganização ou sofrimento psicótico
 - ou quando a sessão sugere piora apesar do uso referido
 - pode valer comunicação para revisão clínica do quadro

Vermelho: tratar como urgência

- Febre referida ou observável
- confusão importante
- rigidez intensa e piora rápida do estado geral durante a sessão ou nas últimas horas.: Acionar avaliação médica no mesmo dia; se houver gravidade evidente
- contatar emergência e rede de apoio
- Retorno rápido de desorganização grave
- intensa desconfiança
- comando alucinatório ou risco de agressão a si ou a terceiros.: Priorizar manejo de crise
- acionar psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhar para emergência quando necessário

Frase clínica

O foco é distinguir estabilização útil de empobrecimento subjetivo, e adesão irregular de recaída do quadro de base.

068 PALMITATO DE PALIPERIDONA

Substância: Palmitato de Paliperidona.

Nomes Comerciais: Palmitato de Paliperidona, Vegapali

Uso comum

- Palmitato de paliperidona é um antipsicótico de ação prolongada, geralmente encontrado em pacientes com esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e quadros com histórico de baixa adesão ao uso oral. No consultório, a leitura clínica costuma se organizar menos por oscilações diárias e mais por mudanças ao longo de semanas após a aplicação, por piora progressiva perto da próxima dose e por sinais de abandono silencioso quando o paciente falta à aplicação. Nas primeiras semanas após início ou regularização, vale acompanhar sedação, lentificação, inquietação corporal e impacto no vínculo; ao longo dos meses, o foco passa a ser estabilidade, funcionamento e efeitos que corroem adesão sem serem espontaneamente trazidos.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Alguns pacientes chegam mais lentificados, sonolentos ou com menor iniciativa verbal, o que pode alterar o ritmo da sessão e ser confundido com retraimento psicótico, depressão ou simples empobrecimento do contato. Quando isso surge após início, regularização ou aplicação recente, vale observar se há preservação do pensamento e do vínculo apesar da queda de energia. Também convém diferenciar de noites mal dormidas, uso concomitante de outras medicações sedativas e desorganização da rotina.

Inquietação corporal: Pode aparecer uma agitação difícil de nomear: o paciente diz estar ansioso, mas o corpo não encontra posição, muda de postura o tempo todo ou relata alívio apenas ao andar. Em sessão, isso pode ser lido como ansiedade habitual, tensão por tema sensível ou aumento de paranoia, quando às vezes o componente corporal é mais proeminente que o conteúdo psíquico. A discriminação depende de situar início temporal, relação com aplicações e presença ou não do padrão ansioso prévio.

Acesso afetivo: Em parte dos pacientes, a sessão fica mais plana, com menor variação emocional, respostas curtas e dificuldade de acessar nuances afetivas. Isso pode corresponder a estabilização de sintomas antes muito invasivos, mas também pode ser vivido como embotamento e reduzir a capacidade de elaboração. Vale comparar com a linha de base: se houve ganho de organização e contato com a realidade, ou se o paciente parece apenas mais apagado e menos disponível para o trabalho terapêutico.

Adesão e intervalo: Como se trata de formulação injetável de longa ação, a adesão irregular costuma aparecer menos como esquecimento diário e mais como atraso, falta à aplicação, minimização de incômodos ou afastamento do seguimento. Na sessão, às vezes o paciente não nomeia diretamente que perdeu a data, mas surgem piora gradual, mais desconfiança, maior desorganização ou retorno de vozes perto do período esperado da próxima aplicação. Eventos de vida, uso de substâncias e ruptura do vínculo com a equipe também podem produzir quadro semelhante, por isso a cronologia é central.

Sintomas persistentes: Mesmo com uso regular, podem permanecer ideias de referência, vozes, retraimento social ou prejuízo funcional, e isso não significa automaticamente falha de tratamento nem resistência. Para o terapeuta, importa notar se há redução de intensidade, maior capacidade de questionar a experiência e melhor manejo cotidiano, em vez de esperar remissão completa em curto prazo. Também é útil distinguir sintoma residual relativamente estável de piora progressiva associada a adesão irregular, estresse ambiental ou uso de álcool e outras drogas.

Sinais físicos visíveis: Ganho de peso, rigidez, expressão facial menos móvel, tremor fino, salivação ou queixa de mal-estar após aplicação podem entrar no campo transferencial como vergonha, irritação ou recusa de continuidade. Esses sinais às vezes são mais observáveis pelo terapeuta do que espontaneamente relatados, sobretudo quando o paciente teme perder autonomia ou ser pressionado. Convém registrar o que mudou no corpo e como isso repercute em autoestima, circulação social e disposição para manter o tratamento."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Alguns pacientes chegam mais lentificados, sonolentos ou com menor iniciativa verbal, o que pode alterar o ritmo da sessão e ser confundido com retraimento psicótico, depressão ou simples empobrecimento do contato. Quando isso surge após início, regularização ou aplicação recente, vale observar se há preservação do pensamento e do vínculo apesar da queda de energia. Também convém diferenciar de noites mal dormidas, uso concomitante de outras medicações sedativas e desorganização da rotina.

Inquietação corporal: Pode aparecer uma agitação difícil de nomear: o paciente diz estar ansioso, mas o corpo não encontra posição, muda de postura o tempo todo ou relata alívio apenas ao andar. Em sessão, isso pode ser lido como ansiedade habitual, tensão por tema sensível ou aumento de paranoia, quando às vezes o componente corporal é mais proeminente que o conteúdo psíquico. A discriminação depende de situar início temporal, relação com aplicações e presença ou não do padrão ansioso prévio.

Acesso afetivo: Em parte dos pacientes, a sessão fica mais plana, com menor variação emocional, respostas curtas e dificuldade de acessar nuances afetivas. Isso pode corresponder a estabilização de sintomas antes muito invasivos, mas também pode ser vivido como embotamento e reduzir a capacidade de elaboração. Vale comparar com a linha de base: se houve ganho de organização e contato com a realidade, ou se o paciente parece apenas mais apagado e menos disponível para o trabalho terapêutico.

Adesão e intervalo: Como se trata de formulação injetável de longa ação, a adesão irregular costuma aparecer menos como esquecimento diário e mais como atraso, falta à aplicação, minimização de incômodos ou afastamento do seguimento. Na sessão, às vezes o paciente não nomeia diretamente que perdeu a data, mas surgem piora gradual, mais desconfiança, maior desorganização ou retorno de vozes perto do período esperado da próxima aplicação. Eventos de vida, uso de substâncias e ruptura do vínculo com a equipe também podem produzir quadro semelhante, por isso a cronologia é central.

Sintomas persistentes: Mesmo com uso regular, podem permanecer ideias de referência, vozes, retraimento social ou prejuízo funcional, e isso não significa automaticamente falha de tratamento nem resistência. Para o terapeuta, importa notar se há redução de intensidade, maior capacidade de questionar a experiência e melhor manejo cotidiano, em vez de esperar remissão completa em curto prazo. Também é útil distinguir sintoma residual relativamente estável de piora progressiva associada a adesão irregular, estresse ambiental ou uso de álcool e outras drogas.

Sinais físicos visíveis: Ganho de peso, rigidez, expressão facial menos móvel, tremor fino, salivação ou queixa de mal-estar após aplicação podem entrar no campo transferencial como vergonha, irritação ou recusa de continuidade. Esses sinais às vezes são mais observáveis pelo terapeuta do que espontaneamente relatados, sobretudo quando o paciente teme perder autonomia ou ser pressionado. Convém registrar o que mudou no corpo e como isso repercute em autoestima, circulação social e disposição para manter o tratamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Palmitato de paliperidona é um antipsicótico de ação prolongada, geralmente encontrado em pacientes com esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e quadros com histórico de baixa adesão ao uso oral. No consultório, a leitura clínica costuma se organizar menos por oscilações diárias e mais por mudanças ao longo de semanas após a aplicação, por piora progressiva perto da próxima dose e por sinais de abandono silencioso quando o paciente falta à aplicação. Nas primeiras semanas após início ou regularização, vale acompanhar sedação, lentificação, inquietação corporal e impacto no vínculo; ao longo dos meses, o foco passa a ser estabilidade, funcionamento e efeitos que corroem adesão sem serem espontaneamente trazidos.

Perguntas úteis

- "Quando essa sensação de ansiedade aparece, ela vem mais como preocupação e medo ou como um incômodo no corpo que melhora se você se levanta ou anda? , Nas últimas semanas, você se percebeu mais estável e organizado por dentro ou mais apagado, como se sentisse menos as coisas? , Essa piora que você notou aconteceu de uma vez ou foi crescendo conforme se aproximava a data da aplicação? , Quando você fica mais quieto na sessão, isso combina com cansaço e sono, com medo de falar, ou com dificuldade de encontrar as palavras? , O que mudou no seu corpo ou na sua disposição desde que começou esse esquema, e o quanto isso tem dado vontade de evitar a próxima aplicação? , Essas vozes ou desconfianças estão com a mesma força de antes, ou você consegue hoje se afastar um pouco delas e seguir a rotina apesar delas?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega progressivamente mais desconfiado
- desorganizado ou com retorno de sintomas perto da próxima aplicação
- pode valer alinhar com o psiquiatra para esclarecer se há atraso
- perda de seguimento ou cobertura clínica insuficiente ao longo do intervalo
- Quando a sessão passa a ser marcada por sonolência
- lentificação importante ou queda funcional que não se explica bem pelo quadro de base
- pode valer comunicar o médico assistente para situar temporalidade e impacto clínico
- Quando surge inquietação corporal persistente
- com dificuldade de permanecer sentado e sofrimento relevante
- pode valer contato com o psiquiatra para diferenciar ansiedade do quadro de um possível efeito relacionado ao tratamento
- Quando sinais físicos visíveis
- ganho de peso ou rigidez começam a corroer adesão e o paciente cogita faltar à aplicação sem dizer isso à equipe
- pode valer alinhar com o médico assistente pela chance de abandono silencioso
- Quando
- após algumas semanas a meses de uso regular

Amarelo: alinhar em breve

- não se observa ganho em organização
- contato com a realidade ou funcionamento
- pode valer comunicação para compartilhar a evolução clínica percebida em sessão

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente aparece muito mais acelerado
- sem dormir
- grandioso ou expansivo de modo incomum para sua linha de base
- com perda de crítica e aumento de impulsividade.: Registrar a mudança de estado e acionar o psiquiatra no mesmo dia; se houver risco comportamental importante
- mobilizar rede de apoio e avaliação de urgência
- O paciente chega confuso
- muito rígido
- febril ou visivelmente adoecido
- com piora rápida do estado geral e dificuldade de sustentar contato.: Interromper o foco psicoterápico e encaminhar para avaliação médica urgente no mesmo dia
- acionando acompanhante ou emergência quando necessário
- Há ideação suicida com intenção
- plano ou perda importante de controle associada a vozes de comando
- intensa desesperança ou desorganização.: Fazer manejo de crise
- acionar rede de apoio e avaliação psiquiátrica imediata ou serviço de emergência conforme o risco

Frase clínica

O foco clínico é distinguir estabilidade real de apagamento, e recaída progressiva de falhas no intervalo entre aplicações.

069 RISPERIDONA

Substância: Risperidona.

Nomes Comerciais: Riss, Risperidona, Risperidona (Port 344/98 - Lista C1), Risperidon, Viverdal, Rispixan, Zargus, Risperdal, Perlid, Risperac

Uso comum

- A risperidona é um antipsicótico que costuma aparecer no consultório em pacientes com sintomas psicóticos, agitação importante, irritabilidade, insônia associada à desorganização, quadros bipolares e, em alguns casos, como adjuvante em depressão ou ansiedade refratária. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto sedação, lentificação, inquietação corporal e mudanças no sono; entre 2 e 6 semanas, pode ficar mais claro se houve redução de desorganização, impulsividade ou intensidade de ideias persecutórias. O ponto central na sessão é diferenciar melhora clínica de embotamento excessivo, além de notar sinais que favorecem abandono silencioso por desconforto corporal, ganho de peso, efeitos sexuais ou adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** No início ou após mudanças recentes no uso, alguns pacientes chegam mais sonolentos, lentificados ou com menor espontaneidade verbal. Isso pode se confundir com retraimento depressivo, exaustão por noites ruins, uso de outras medicações sedativas ou simples alívio de uma fase de agitação prévia. Vale comparar com a linha de base da sessão: há menos sofrimento e mais organização, ou apenas menos energia e menos acesso afetivo?

Inquietação corporal: Em parte dos pacientes, aparece um desconforto motor difícil de nomear: necessidade de se mexer, dificuldade para permanecer sentado, irritabilidade sem gatilho claro. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como ansiedade habitual, tensão relacional ou impaciência defensiva, quando às vezes o corpo parece estar mais implicado do que o conteúdo psíquico. A discriminação depende de observar se a inquietação melhora ao falar de temas ansiogênicos ou se persiste de modo relativamente contínuo, mesmo sem aumento proporcional da ansiedade subjetiva.

Embotamento e contato: A redução de intensidade emocional pode vir acompanhada de maior organização e menos sofrimento, mas às vezes o paciente descreve estar 'mais apagado', com menos iniciativa, menos prazer e menor capacidade de se implicar afetivamente. Na sessão, isso pode parecer melhora porque há menos turbulência, embora o vínculo mostre empobrecimento do acesso afetivo e da elaboração. Também pode se confundir com efeito residual do quadro de base, defesa após crise ou desinvestimento decorrente de eventos de vida.

Apetite, peso e imagem: Aumento de apetite, mudanças corporais e incômodo com o próprio corpo podem surgir ao longo das primeiras semanas e meses, muitas vezes antes de o paciente trazer isso espontaneamente. Em terapia, isso pode aparecer como vergonha, evitação sexual, irritabilidade, sensação de perda de controle ou abandono silencioso do tratamento. Convém não reduzir automaticamente a mudança corporal ao medicamento, porque rotina, compulsão alimentar, sedentarismo, humor e outras medicações também podem participar.

Sexualidade e prolactina: Queda de libido, dificuldade de excitação, alterações menstruais, desconforto mamário ou secreção mamilar podem repercutir no vínculo amoroso e na autoestima, e às vezes o paciente fala primeiro em afastamento do parceiro ou em 'desinteresse geral'. Na sessão, isso pode ser confundido com conflito conjugal, depressão, trauma sexual ou desgaste relacional. Quando o tempo de aparecimento coincide com o uso e há constrangimento em nomear o tema, cresce o risco de adesão irregular sem aviso.

Adesão e descontinuação: A risperidona pode ser abandonada de forma intermitente quando o paciente se sente excessivamente sedado, incomodado com o corpo, sexualmente afetado ou quando melhora parcialmente e conclui que 'não precisa mais'. Em sessão, isso pode aparecer como oscilação abrupta entre maior organização e retorno de irritabilidade, insônia, desconfiança ou desorganização, sem que o paciente inicialmente associe à irregularidade do uso. O terapeuta ganha muito ao mapear a sequência temporal entre mudanças no padrão da sessão, rotina e continuidade do tratamento."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** No início ou após mudanças recentes no uso, alguns pacientes chegam mais sonolentos, lentificados ou com menor espontaneidade verbal. Isso pode se confundir com retraimento depressivo, exaustão por noites ruins, uso de outras medicações sedativas ou simples alívio de uma fase de agitação prévia. Vale comparar com a linha de base da sessão: há menos sofrimento e mais organização, ou apenas menos energia e menos acesso afetivo?

Inquietação corporal: Em parte dos pacientes, aparece um desconforto motor difícil de nomear: necessidade de se mexer, dificuldade para permanecer sentado, irritabilidade sem gatilho claro. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como ansiedade habitual, tensão relacional ou impaciência defensiva, quando às vezes o corpo parece estar mais implicado do que o conteúdo psíquico. A discriminação depende de observar se a inquietação melhora ao falar de temas ansiogênicos ou se persiste de modo relativamente contínuo, mesmo sem aumento proporcional da ansiedade subjetiva.

Embotamento e contato: A redução de intensidade emocional pode vir acompanhada de maior organização e menos sofrimento, mas às vezes o paciente descreve estar 'mais apagado', com menos iniciativa, menos prazer e menor capacidade de se implicar afetivamente. Na sessão, isso pode parecer melhora porque há menos turbulência, embora o vínculo mostre empobrecimento do acesso afetivo e da elaboração. Também pode se confundir com efeito residual do quadro de base, defesa após crise ou desinvestimento decorrente de eventos de vida.

Apetite, peso e imagem: Aumento de apetite, mudanças corporais e incômodo com o próprio corpo podem surgir ao longo das primeiras semanas e meses, muitas vezes antes de o paciente trazer isso espontaneamente. Em terapia, isso pode aparecer como vergonha, evitação sexual, irritabilidade, sensação de perda de controle ou abandono silencioso do tratamento. Convém não reduzir automaticamente a mudança corporal ao medicamento, porque rotina, compulsão alimentar, sedentarismo, humor e outras medicações também podem participar.

Sexualidade e prolactina: Queda de libido, dificuldade de excitação, alterações menstruais, desconforto mamário ou secreção mamilar podem repercutir no vínculo amoroso e na autoestima, e às vezes o paciente fala primeiro em afastamento do parceiro ou em 'desinteresse geral'. Na sessão, isso pode ser confundido com conflito conjugal, depressão, trauma sexual ou desgaste relacional. Quando o tempo de aparecimento coincide com o uso e há constrangimento em nomear o tema, cresce o risco de adesão irregular sem aviso.

Adesão e descontinuação: A risperidona pode ser abandonada de forma intermitente quando o paciente se sente excessivamente sedado, incomodado com o corpo, sexualmente afetado ou quando melhora parcialmente e conclui que 'não precisa mais'. Em sessão, isso pode aparecer como oscilação abrupta entre maior organização e retorno de irritabilidade, insônia, desconfiança ou desorganização, sem que o paciente inicialmente associe à irregularidade do uso. O terapeuta ganha muito ao mapear a sequência temporal entre mudanças no padrão da sessão, rotina e continuidade do tratamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A risperidona é um antipsicótico que costuma aparecer no consultório em pacientes com sintomas psicóticos, agitação importante, irritabilidade, insônia associada à desorganização, quadros bipolares e, em alguns casos, como adjuvante em depressão ou ansiedade refratária. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto sedação, lentificação, inquietação corporal e mudanças no sono; entre 2 e 6 semanas, pode ficar mais claro se houve redução de desorganização, impulsividade ou intensidade de ideias persecutórias. O ponto central na sessão é diferenciar melhora clínica de embotamento excessivo, além de notar sinais que favorecem abandono silencioso por desconforto corporal, ganho de peso, efeitos sexuais ou adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais travado ou apagado, isso vem junto de menos sofrimento e mais clareza, ou parece mais uma perda de vitalidade e de acesso ao que sente? , Essa inquietação que aparece no corpo melhora quando você entende o que está te deixando ansioso, ou continua mesmo quando a cabeça não parece especialmente acelerada? , Nos dias em que você dorme mais ou chega mais lento, você percebe descanso e organização maiores, ou fica com sensação de peso, confusão e pouca iniciativa? , Essa mudança no interesse sexual parece ligada ao vínculo com a pessoa, ao seu humor de modo geral, ou começou como algo mais corporal e relativamente novo no período do tratamento? , Quando sua semana oscila muito, você consegue lembrar se isso acompanha mudanças na rotina, estresse e sono, ou se coincide com dias em que o uso do remédio ficou irregular? , A redução das ideias de perseguição, irritação ou agitação veio com mais capacidade de pensar e se relacionar, ou com uma sensação de estar distante de tudo?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- chega muito sedado ou relata lentificação que compromete trabalho
- estudo ou cuidado cotidiano
- pode valer alinhar com o psiquiatra para avaliar impacto funcional e sustentação do tratamento
- Quando surge inquietação corporal persistente
- especialmente se o paciente pensa em parar por conta própria por não tolerar ficar parado
- pode valer alinhar com o psiquiatra para esclarecer a leitura clínica do quadro
- Quando aparecem alterações sexuais ou sinais como irregularidade menstrual
- secreção mamilar ou importante desconforto com o corpo
- pode valer comunicar o médico assistente porque esses fatores frequentemente favorecem abandono silencioso
- Quando há ganho de peso relevante com vergonha
- retraimento social ou piora importante da autoestima
- pode valer alinhar com o psiquiatra pelo impacto na adesão e no funcionamento

Amarelo: alinhar em breve

- Quando
- após algumas semanas
- não se observa redução de desorganização
- agitação ou ideias persecutórias
- ou há piora apesar de aparente uso regular
- pode valer comunicar o médico assistente para revisão do quadro e da adesão
- Quando o paciente relata interrupções frequentes
- uso intermitente ou retorno de sintomas após parar por conta própria
- pode valer alinhar com o psiquiatra porque a irregularidade dificulta a leitura clínica da evolução

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente apresenta febre
- rigidez muscular evidente
- confusão importante
- sudorese intensa ou rebaixamento acentuado do estado geral durante a sessão ou em relato muito recente.: Tratar como urgência clínica
- acionar avaliação médica no mesmo dia e mobilizar rede de apoio ou emergência quando necessário
- Há retorno rápido de forte desorganização
- intensa desconfiança
- agitação marcada ou comportamento de risco após interrupção recente por conta própria.: Avaliar segurança imediata
- acionar psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e considerar encaminhamento para urgência conforme o grau de risco
- Emergem ideias de morte
- autoagressão ou heteroagressividade em contexto de piora aguda
- confusão ou intensificação de sintomas psicóticos.: Fazer manejo de risco imediatamente
- acionar psiquiatra e rede de apoio hoje e recorrer à emergência se a contenção ambulatorial não parecer suficiente

Frase clínica

Na terapia, o foco com risperidona é distinguir contenção útil de embotamento excessivo e reconhecer cedo o que favorece adesão irregular.

070 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA

Substância: Cloridrato de Clorpromazina.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Clorpromazina, Longactil, Clorpromaz, Amplictil

Uso comum

- A clorpromazina é um antipsicótico de primeira geração que pode aparecer no consultório em quadros psicóticos, agitação importante, mania e, em alguns contextos, como adjuvante para insônia ou ansiedade intensa. Nas primeiras semanas, o terapeuta costuma acompanhar mais de perto sedação, lentificação e queda de iniciativa, que podem alterar bastante o padrão da sessão antes de qualquer melhora mais consistente do quadro de base. Ao longo das semanas seguintes, vale observar se há redução de desorganização e agitação sem perda excessiva de acesso afetivo, além de sinais físicos visíveis que possam comprometer adesão ou levar a abandono silencioso.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, dificuldade de sustentar atenção e aparência de cansaço podem dominar a sessão, sobretudo no início ou após mudanças recentes no uso. Isso pode ser confundido com retraimento depressivo, exaustão por privação de sono ou efeito de outras medicações sedativas. A pista clínica costuma estar na mudança do ritmo habitual da sessão: o paciente parece menos mobilizado, mas nem sempre mais triste ou mais desesperançado.

Agitação e controle: Quando a medicação está ajudando, pode haver menos impulsividade, menor tensão motora e redução de agitação que antes invadia a sessão. Ainda assim, uma aparente tranquilização pode mascarar embotamento, submissão excessiva ou simples esgotamento após crise recente. Vale comparar com a linha de base: houve ganho de organização e capacidade de pensar, ou apenas redução global da expressão e da iniciativa?

Cognição e contato: Alguns pacientes chegam mais lentificados, com dificuldade de encadear ideias, responder com prontidão ou manter o fio da conversa. Isso pode decorrer do próprio quadro psicótico, de sedação medicamentosa, de uso irregular ou de noites mal dormidas. O ponto útil na sessão é diferenciar se a pessoa está mais acessível e coerente apesar da lentificação, ou se segue confusa, desconfiada ou internamente tomada por experiências que competem com o contato terapêutico.

Sinais motores: Inquietação corporal, rigidez, postura endurecida, redução de gestos, tremor fino ou queixa de corpo preso podem aparecer e interferir no vínculo e na capacidade de permanecer na sessão. Esses sinais às vezes são lidos como ansiedade, resistência, tensão interpessoal ou traço de personalidade, quando podem estar relacionados ao tratamento. Também vale lembrar que agitação psicótica e ansiedade basal podem produzir apresentação parecida; observar o corpo ao longo da sessão ajuda a discriminar.

Adesão e abandono silencioso: A clorpromazina pode gerar incômodos perceptíveis o bastante para o paciente reduzir, pular ou interromper o uso sem comunicar espontaneamente, especialmente quando sente que ficou apagado, travado ou excessivamente sonolento. Na sessão, isso pode surgir como oscilação abrupta entre dias muito sedados e retorno de agitação, insônia ou desorganização. Nem toda piora indica progressão do quadro; às vezes o padrão temporal sugere uso irregular motivado por tolerabilidade ruim.

Sinais físicos visíveis: Boca seca, constipação referida, visão turva, tontura ao levantar e queixas de mal-estar corporal podem aparecer no relato e afetar presença, humor e disponibilidade psíquica. Em sessão, o paciente pode mudar muito de posição, pedir água, parecer desconfortável ou evitar sair de casa por receio desses efeitos. Parte disso pode ser atribuída a ansiedade somática, desidratação, outras medicações ou condição clínica associada, por isso o contexto e a temporalidade importam."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, dificuldade de sustentar atenção e aparência de cansaço podem dominar a sessão, sobretudo no início ou após mudanças recentes no uso. Isso pode ser confundido com retraimento depressivo, exaustão por privação de sono ou efeito de outras medicações sedativas. A pista clínica costuma estar na mudança do ritmo habitual da sessão: o paciente parece menos mobilizado, mas nem sempre mais triste ou mais desesperançado.

Agitação e controle: Quando a medicação está ajudando, pode haver menos impulsividade, menor tensão motora e redução de agitação que antes invadia a sessão. Ainda assim, uma aparente tranquilização pode mascarar embotamento, submissão excessiva ou simples esgotamento após crise recente. Vale comparar com a linha de base: houve ganho de organização e capacidade de pensar, ou apenas redução global da expressão e da iniciativa?

Cognição e contato: Alguns pacientes chegam mais lentificados, com dificuldade de encadear ideias, responder com prontidão ou manter o fio da conversa. Isso pode decorrer do próprio quadro psicótico, de sedação medicamentosa, de uso irregular ou de noites mal dormidas. O ponto útil na sessão é diferenciar se a pessoa está mais acessível e coerente apesar da lentificação, ou se segue confusa, desconfiada ou internamente tomada por experiências que competem com o contato terapêutico.

Sinais motores: Inquietação corporal, rigidez, postura endurecida, redução de gestos, tremor fino ou queixa de corpo "preso" podem aparecer e interferir no vínculo e na capacidade de permanecer na sessão. Esses sinais às vezes são lidos como ansiedade, resistência, tensão interpessoal ou traço de personalidade, quando podem estar relacionados ao tratamento. Também vale lembrar que agitação psicótica e ansiedade basal podem produzir apresentação parecida; observar o corpo ao longo da sessão ajuda a discriminar.

Adesão e abandono silencioso: A clorpromazina pode gerar incômodos perceptíveis o bastante para o paciente reduzir, pular ou interromper o uso sem comunicar espontaneamente, especialmente quando sente que ficou "apagado", travado ou excessivamente sonolento. Na sessão, isso pode surgir como oscilação abrupta entre dias muito sedados e retorno de agitação, insônia ou desorganização. Nem toda piora indica progressão do quadro; às vezes o padrão temporal sugere uso irregular motivado por tolerabilidade ruim.

Sinais físicos visíveis: Boca seca, constipação referida, visão turva, tontura ao levantar e queixas de mal-estar corporal podem aparecer no relato e afetar presença, humor e disponibilidade psíquica. Em sessão, o paciente pode mudar muito de posição, pedir água, parecer desconfortável ou evitar sair de casa por receio desses efeitos. Parte disso pode ser atribuída a ansiedade somática, desidratação, outras medicações ou condição clínica associada, por isso o contexto e a temporalidade importam.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A clorpromazina é um antipsicótico de primeira geração que pode aparecer no consultório em quadros psicóticos, agitação importante, mania e, em alguns contextos, como adjuvante para insônia ou ansiedade intensa. Nas primeiras semanas, o terapeuta costuma acompanhar mais de perto sedação, lentificação e queda de iniciativa, que podem alterar bastante o padrão da sessão antes de qualquer melhora mais consistente do quadro de base. Ao longo das semanas seguintes, vale observar se há redução de desorganização e agitação sem perda excessiva de acesso afetivo, além de sinais físicos visíveis que possam comprometer adesão ou levar a abandono silencioso.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais parado ou sonolento, isso vem junto de tristeza e desesperança ou parece mais um corpo pesado e uma mente lenta? , Essa sensação de inquietação no corpo parece com a sua ansiedade habitual ou é mais como não conseguir ficar parado mesmo quando você não está preocupado com nada específico? , Desde que começou a usar essa medicação, você se percebe mais organizado por dentro ou apenas menos expressivo e com menos iniciativa? , Nos dias em que você fica pior, isso aconteceu de forma contínua ao longo da semana ou alternou com dias em que você tomou diferente, esqueceu ou evitou tomar? , Quando sua fala ou seu pensamento ficam mais lentos, você sente que está mais claro por dentro ou ainda confuso, desconfiado ou tomado por coisas que atrapalham nosso contato aqui? , Esse desconforto físico tem feito você evitar tomar a medicação, adiar horários ou mudar algo por conta própria sem comentar com o médico?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente muito sedado
- com prejuízo claro de funcionamento e risco de abandono silencioso
- pode valer alinhar com o psiquiatra para informar o impacto clínico observado em sessão
- Quando surgem rigidez
- tremor
- inquietação corporal importante ou sensação de corpo travado que passam a interferir na permanência em sessão e na adesão
- pode valer comunicar o médico assistente para avaliação
- Quando há oscilação entre dias de intensa sonolência e retorno de agitação
- insônia ou desorganização
- pode valer contato com o psiquiatra porque o padrão pode sugerir uso irregular ou tolerabilidade ruim
- Quando
- após algumas semanas
- a sessão segue marcada por desorganização importante
- desconfiança ou agitação sem ganho observável de contato e organização
- pode valer alinhar com o médico para revisão do quadro clínico

Amarelo: alinhar em breve

- Quando efeitos físicos referidos
- como tontura ao levantar
- constipação importante ou mal-estar persistente
- começam a comprometer rotina e continuidade do tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- o paciente apresenta febre referida ou aparente
- confusão importante
- rigidez acentuada e piora rápida do estado geral.: Tratar como urgência clínica
- acionar avaliação médica no mesmo dia e recorrer à emergência se não houver retaguarda imediata
- Há rebaixamento importante do nível de consciência
- dificuldade marcante de se manter desperto ou sinais de colapso ao levantar
- com risco de queda.: Interromper o manejo habitual da sessão
- garantir segurança imediata e acionar suporte médico no mesmo dia
- O paciente retorna com agravamento importante de desorganização
- agitação ou risco para si ou para outros após interrupção por conta própria ou uso muito irregular.: Avaliar risco imediato
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- considerando emergência quando necessário

Frase clínica

O foco é distinguir contenção útil de sedação excessiva, observando sinais motores e adesão silenciosamente ameaçada.

071 CLORIDRATO DE LEVOMEPRMAZINA

Substância: Cloridrato de Levomepromazina.

Nomes Comerciais: Levozine, Neozine

Uso comum

- A levomepromazina é um antipsicótico fenotiazínico com perfil fortemente sedativo, encontrado em alguns quadros psicóticos, agitação importante, insônia refratária em contexto psiquiátrico e, por vezes, em manejo paliativo. No consultório de terapia, o eixo principal costuma ser menos a remissão de sintomas nucleares e mais a mudança do estado de vigília, do ritmo da sessão e do acesso cognitivo-afetivo. Sonolência, lentificação e sensação de “corpo pesado” podem aparecer já nos primeiros dias e se manter ao longo das semanas; oscilações entre dias mais sedados e dias mais reativos também podem refletir adesão irregular, uso concomitante de outras medicações ou variação do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sedação":** A sessão pode ficar marcada por sonolência visível, fala mais lenta, dificuldade de sustentar atenção e menor espontaneidade associativa. Em alguns pacientes isso é vivido como alívio da agitação; em outros, como empobrecimento subjetivo ou perda de presença. Vale diferenciar esse rebaixamento do nível de alerta de piora depressiva, exaustão por privação de sono, uso de álcool ou outras substâncias e mudanças recentes na rotina. Quando a sedação varia muito entre encontros, adesão irregular ou uso apenas em alguns dias entram no campo de hipótese.

Acesso afetivo: Pode surgir um paciente menos reativo, com afeto mais amortecido e menor capacidade de nomear nuances internas, o que às vezes é confundido com melhora clínica ampla. Em parte dos casos, a redução da intensidade emocional ajuda a conter desorganização e impulsividade; em outros, empobrece a elaboração e altera o padrão habitual do vínculo terapêutico. Convém observar se houve redução proporcional do sofrimento e ganho funcional, ou se o paciente apenas ficou mais "apagado", sem mudança consistente na qualidade da experiência psíquica.

Hipotensão e corpo: Tontura ao levantar, sensação de fraqueza, instabilidade postural e queixa de corpo muito pesado podem aparecer no relato e também ser percebidas na entrada ou saída da sessão. Esses sinais podem ser lidos apressadamente como ansiedade somatizada, descondicionamento físico ou desânimo depressivo, mas ganham outro peso quando se repetem em proximidade temporal com o uso da medicação. Se o paciente descreve quase quedas, necessidade de se apoiar ou mal-estar importante ao mudar de posição, vale registrar com precisão e considerar comunicação clínica.

Cognição na sessão: A lentificação pode afetar memória recente, encadeamento narrativo e capacidade de acompanhar interpretações mais complexas. Nem sempre isso indica piora do transtorno de base; às vezes o paciente está menos delirante ou menos agitado, porém também menos disponível para simbolização fina. A discriminação clínica passa por comparar com a baseline: houve perda nova de clareza e iniciativa ou apenas redução de aceleração prévia? Mudanças abruptas entre sessões também pedem atenção para adesão irregular e associação com outras medicações sedativas.

Adesão silenciosa: Com essa medicação, abandono parcial ou uso intermitente pode ocorrer sem anúncio explícito, especialmente quando o paciente se sente excessivamente sedado, "travado" ou incapaz de funcionar no dia seguinte. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação marcada entre encontros, justificativas vagas para dias muito diferentes ou ambivalência em relação ao benefício obtido. Também é fácil confundir esse padrão com instabilidade do quadro psiquiátrico em si. Perguntas concretas sobre regularidade do uso e sobre o que mudou na rotina ajudam a discriminar tolerabilidade ruim de recaída espontânea.

Sinais extrapiramidais: Inquietação corporal incomum, rigidez, expressão facial mais fixa, fala menos fluida ou desconforto motor podem aparecer de modo sutil e ser confundidos com ansiedade, retraimento defensivo ou embotamento. O ponto clínico é observar se o paciente descreve um mal-estar físico de não conseguir ficar parado, travamento corporal ou sensação de corpo endurecido, sobretudo quando isso não fazia parte do padrão anterior. Como esses sinais

podem comprometer adesão e ser mal nomeados pelo paciente, a observação direta do terapeuta tem valor especial."

O que observar em sessão

- **Sedação:** A sessão pode ficar marcada por sonolência visível, fala mais lenta, dificuldade de sustentar atenção e menor espontaneidade associativa. Em alguns pacientes isso é vivido como alívio da agitação; em outros, como empobrecimento subjetivo ou perda de presença. Vale diferenciar esse rebaixamento do nível de alerta de piora depressiva, exaustão por privação de sono, uso de álcool ou outras substâncias e mudanças recentes na rotina. Quando a sedação varia muito entre encontros, adesão irregular ou uso apenas em alguns dias entram no campo de hipótese.

Acesso afetivo: Pode surgir um paciente menos reativo, com afeto mais amortecido e menor capacidade de nomear nuances internas, o que às vezes é confundido com melhora clínica ampla. Em parte dos casos, a redução da intensidade emocional ajuda a conter desorganização e impulsividade; em outros, empobrece a elaboração e altera o padrão habitual do vínculo terapêutico. Convém observar se houve redução proporcional do sofrimento e ganho funcional, ou se o paciente apenas ficou mais “apagado”, sem mudança consistente na qualidade da experiência psíquica.

Hipotensão e corpo: Tontura ao levantar, sensação de fraqueza, instabilidade postural e queixa de corpo muito pesado podem aparecer no relato e também ser percebidas na entrada ou saída da sessão. Esses sinais podem ser lidos apressadamente como ansiedade somatizada, descondicionamento físico ou desânimo depressivo, mas ganham outro peso quando se repetem em proximidade temporal com o uso da medicação. Se o paciente descreve quase quedas, necessidade de se apoiar ou mal-estar importante ao mudar de posição, vale registrar com precisão e considerar comunicação clínica.

Cognição na sessão: A lentificação pode afetar memória recente, encadeamento narrativo e capacidade de acompanhar interpretações mais complexas. Nem sempre isso indica piora do transtorno de base; às vezes o paciente está menos delirante ou menos agitado, porém também menos disponível para simbolização fina. A discriminação clínica passa por comparar com a baseline: houve perda nova de clareza e iniciativa ou apenas redução de aceleração prévia? Mudanças abruptas entre sessões também pedem atenção para adesão irregular e associação com outras medicações sedativas.

Adesão silenciosa: Com essa medicação, abandono parcial ou uso intermitente pode ocorrer sem anúncio explícito, especialmente quando o paciente se sente excessivamente sedado, “travado” ou incapaz de funcionar no dia seguinte. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação marcada entre encontros, justificativas vagas para dias muito diferentes ou ambivalência em relação ao benefício obtido. Também é fácil confundir esse padrão com instabilidade do quadro psiquiátrico em si. Perguntas concretas sobre regularidade do uso e sobre o que mudou na rotina ajudam a discriminar tolerabilidade ruim de recaída espontânea.

Sinais extrapiramidais: Inquietação corporal incomum, rigidez, expressão facial mais fixa, fala menos fluida ou desconforto motor podem aparecer de modo sutil e ser confundidos com ansiedade, retraimento defensivo ou embotamento. O ponto clínico é observar se o paciente descreve um mal-estar físico de não conseguir ficar parado, travamento corporal ou sensação de corpo endurecido, sobretudo quando isso não fazia parte do padrão anterior. Como esses sinais

podem comprometer adesão e ser mal nomeados pelo paciente, a observação direta do terapeuta tem valor especial.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A levomepromazina é um antipsicótico fenotiazínico com perfil fortemente sedativo, encontrado em alguns quadros psicóticos, agitação importante, insônia refratária em contexto psiquiátrico e, por vezes, em manejo paliativo. No consultório de terapia, o eixo principal costuma ser menos a remissão de sintomas nucleares e mais a mudança do estado de vigília, do ritmo da sessão e do acesso cognitivo-afetivo. Sonolência, lentificação e sensação de “corpo pesado” podem aparecer já nos primeiros dias e se manter ao longo das semanas; oscilações entre dias mais sedados e dias mais reativos também podem refletir adesão irregular, uso concomitante de outras medicações ou variação do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais apagado ou sonolento, isso vem junto de alívio da agitação ou parece mais um impedimento para pensar, trabalhar e se manter presente? , Essa dificuldade de se concentrar começou como uma continuação do seu quadro anterior ou apareceu de um jeito novo, mais corporal, depois que sua rotina de medicação mudou? , Quando você fica mais quieto na sessão, por dentro também há menos sofrimento e mais clareza, ou você sente que continua mal, só que com menos força para reagir? , Nos dias em que você se sente muito diferente, o que muda mais: seu humor e seus pensamentos, ou seu nível de sono, tontura, lentidão e disposição física? , Essa inquietação no corpo parece a sua ansiedade habitual, com pensamentos acelerados e preocupação, ou é mais uma sensação física de não conseguir se acomodar? , Quando você deixa de tomar ou toma de modo diferente do habitual, o que costuma mudar primeiro no seu dia e na forma como você chega à sessão?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente muito sonolento
- Lentificado ou com prejuízo claro para sustentar a sessão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para avaliar impacto funcional e tolerabilidade
- Quando surgem tontura importante ao levantar
- quase quedas ou instabilidade corporal observável
- pode valer comunicar o médico assistente pela repercussão na segurança e na adesão
- Quando a redução da reatividade emocional parece mais um apagamento global do que melhora do quadro
- pode valer contato com o psiquiatra para discriminar benefício clínico de excesso de sedação
- Quando o paciente descreve uso intermitente
- omissões frequentes ou abandono silencioso por se sentir travado ou sedado demais
- pode valer alinhar com o médico para evitar leitura equivocada de recaída ou resistência
- Quando aparecem inquietação motora nova
- rigidez ou desconforto corporal persistente que não se explicam pelo padrão ansioso habitual

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicação clínica para revisão do quadro
- Quando não há ganho clínico perceptível após algumas semanas
- mas há sedação relevante e empobrecimento da participação na sessão
- pode valer discutir com o psiquiatra a relação entre benefício observado e custo subjetivo

Vermelho: tratar como urgência

- Rebaixamento importante do nível de consciência
- confusão acentuada
- fala muito desconexa ou dificuldade marcante de se manter desperto e orientado na sessão.: Suspende o trabalho psicoterápico do momento e acionar avaliação médica no mesmo dia
- com rede de apoio e emergência se necessário
- Febre acompanhada de rigidez intensa
- piora abrupta do estado geral
- sudorese importante e alteração visível do contato na sessão.: Tratar como urgência clínica e encaminhar para avaliação médica imediata
- acionando emergência quando não houver retaguarda rápida

Frase clínica

Com levomepromazina, o foco costuma ser distinguir contenção útil de sedação excessiva que empobrece presença, elaboração e adesão.

072 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA

Substância: Cloridrato de Tioridazina.

Nomes Comerciais: Unitidazin, Melleril

Uso comum

- A tioridazina é um antipsicótico mais antigo, hoje menos frequente no consultório, mas que pode aparecer em pacientes com quadros psicóticos crônicos, agitação importante ou uso prolongado iniciado há anos. Na terapia, costuma importar menos o mecanismo e mais como o paciente chega: mais lentificado, sonolento, com menor espontaneidade, por vezes com queixas corporais que interferem no vínculo e na continuidade do tratamento. Mudanças podem surgir nos primeiros dias após início ou retomada, enquanto efeitos de estabilização do quadro podem levar algumas semanas; interrupções irregulares também podem produzir oscilação clínica difícil de ler. O ponto central é diferenciar sedação e embotamento do medicamento de retraimento psicótico, depressão, desorganização do sono ou adesão inconsistente.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Em sessão, o paciente pode aparecer mais sonolento, com fala mais lenta, menor iniciativa associativa e dificuldade para sustentar atenção. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento no processo ou agravamento negativo do quadro psicótico, quando às vezes acompanha períodos de uso mais regular ou recente retomada. Também vale considerar privação de sono, uso de álcool, outras medicações sedativas e horários irregulares de tomada como fatores que confundem a leitura clínica.

Embotamento afetivo: Alguns pacientes ficam mais planos na expressão emocional, com menos variação afetiva e menor acesso a nuances internas, o que pode alterar a qualidade da elaboração e da transferência. Em parte dos casos isso acompanha redução de agitação e de sofrimento persecutório; em outros, aproxima-se mais de um amortecimento subjetivo que o próprio paciente estranha. A distinção com sintomas negativos, defesa dissociativa, esgotamento crônico ou retraimento após eventos de vida depende de comparar com a linha de base e com a temporalidade da mudança.

Cognição e ritmo: Pode haver lentificação do pensamento, dificuldade de acompanhar encadeamentos mais longos e menor fluidez verbal, especialmente em sessões mais exigentes do ponto de vista reflexivo. Esse padrão pode se confundir com desorganização do quadro de base, baixa escolarização, ansiedade intensa ou fadiga acumulada. Quando oscila muito entre sessões, vale suspeitar menos de traço estável e mais de variação de adesão, horário de uso, privação de sono ou associação com outras substâncias.

Sinais físicos visíveis: Boca seca, aspecto cansado, queixa de visão turva, constipação referida de passagem ou desconforto corporal inespecífico podem aparecer e afetar presença, humor e disponibilidade para o trabalho terapêutico. Às vezes o paciente não nomeia isso como efeito de medicação, mas como mal-estar geral, irritabilidade ou dificuldade de sair de casa. Esses elementos também podem decorrer de outras medicações, condições clínicas e hidratação precária, por isso o valor está menos em atribuir causa e mais em registrar o padrão e seu impacto funcional.

Adesão e oscilação: Como se trata de uma medicação que pode ser vivida como pesada, alguns pacientes reduzem, pulam ou interrompem por conta própria sem trazer isso espontaneamente. Na sessão, isso pode aparecer como alternância entre maior contenção e maior agitação, retorno de desconfiança, piora do sono ou narrativa pouco consistente sobre a rotina. Eventos de vida estressantes e uso concomitante de outras substâncias podem produzir oscilação semelhante, então a discriminação depende de explorar a sequência temporal com cuidado e sem tom acusatório."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Em sessão, o paciente pode aparecer mais sonolento, com fala mais lenta, menor iniciativa associativa e dificuldade para sustentar atenção. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento no processo ou agravamento negativo do quadro psicótico, quando às vezes acompanha períodos de uso mais regular ou recente retomada. Também vale considerar privação de sono, uso de álcool, outras medicações sedativas e horários irregulares de tomada como fatores que confundem a leitura clínica.

Embotamento afetivo: Alguns pacientes ficam mais planos na expressão emocional, com menos variação afetiva e menor acesso a nuances internas, o que pode alterar a qualidade da elaboração e da transferência. Em parte dos casos isso acompanha redução de agitação e de sofrimento persecutório; em outros, aproxima-se mais de um amortecimento subjetivo que o próprio paciente estranha. A distinção com sintomas negativos, defesa dissociativa, esgotamento crônico ou retraimento após eventos de vida depende de comparar com a linha de base e com a temporalidade da mudança.

Cognição e ritmo: Pode haver lentificação do pensamento, dificuldade de acompanhar encadeamentos mais longos e menor fluidez verbal, especialmente em sessões mais exigentes do ponto de vista reflexivo. Esse padrão pode se confundir com desorganização do quadro de base, baixa escolarização, ansiedade intensa ou fadiga acumulada. Quando oscila muito entre sessões, vale suspeitar menos de traço estável e mais de variação de adesão, horário de uso, privação de sono ou associação com outras substâncias.

Sinais físicos visíveis: Boca seca, aspecto cansado, queixa de visão turva, constipação referida de passagem ou desconforto corporal inespecífico podem aparecer e afetar presença, humor e disponibilidade para o trabalho terapêutico. Às vezes o paciente não nomeia isso como efeito de medicação, mas como mal-estar geral, irritabilidade ou dificuldade de sair de casa. Esses elementos também podem decorrer de outras medicações, condições clínicas e hidratação precária, por isso o valor está menos em atribuir causa e mais em registrar o padrão e seu impacto funcional.

Adesão e oscilação: Como se trata de uma medicação que pode ser vivida como pesada, alguns pacientes reduzem, pulam ou interrompem por conta própria sem trazer isso espontaneamente. Na sessão, isso pode aparecer como alternância entre maior contenção e maior agitação, retorno de desconfiança, piora do sono ou narrativa pouco consistente sobre a rotina. Eventos de vida estressantes e uso concomitante de outras substâncias podem produzir oscilação semelhante, então a discriminação depende de explorar a sequência temporal com cuidado e sem tom acusatório.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A tioridazina é um antipsicótico mais antigo, hoje menos frequente no consultório, mas que pode aparecer em pacientes com quadros psicóticos crônicos, agitação importante ou uso prolongado iniciado há anos. Na terapia, costuma importar menos o mecanismo e mais como o paciente chega: mais lentificado, sonolento, com menor espontaneidade, por vezes com queixas corporais que interferem no vínculo e na continuidade do tratamento. Mudanças podem surgir nos primeiros dias após início ou retomada, enquanto efeitos de estabilização do quadro podem levar algumas semanas; interrupções irregulares também podem produzir oscilação clínica difícil de ler. O ponto central é diferenciar sedação e embotamento do medicamento de retraimento psicótico, depressão, desorganização do sono ou adesão inconsistente.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais travado ou sonolento, isso parece constante ao longo do dia ou varia bastante de um dia para o outro? , Essa sensação de estar mais apagado vem junto com menos sofrimento e menos confusão, ou vem mais como se você estivesse distante de si mesmo? , Nas semanas em que você ficou mais desconfiado, agitado ou sem dormir bem, houve também alguma mudança na sua rotina com a medicação ou no uso de álcool e outras substâncias? , Quando sua fala ou seu pensamento ficam mais lentos aqui na sessão, você percebe isso também em tarefas simples do dia a dia ou mais em momentos de cansaço e tensão? , O que mudou primeiro: o mal-estar corporal e a sonolência, ou a piora do humor, do sono e da convivência com as pessoas?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente muito sonolento
- lentificado ou com prejuízo claro para sustentar a sessão e a rotina
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisar se há impacto clínico relevante do tratamento em curso
- Quando surgem queixas corporais persistentes como visão turva
- boca muito seca
- constipação importante ou mal-estar que favorece abandono silencioso
- pode valer comunicar o médico assistente pela repercussão na adesão e no funcionamento
- Quando há oscilação marcada entre contenção e retorno de agitação
- desconfiança ou insônia associada a uso irregular ou interrupção não claramente assumida
- pode valer contato com o psiquiatra para situar a sequência clínica
- Quando o paciente passa a evitar sair
- dirigir ou realizar atividades por tontura
- sonolência ou sensação de fraqueza
- pode valer alinhar com o médico assistente pelo impacto funcional e pelo risco indireto
- Quando não se observa melhora mínima do quadro-alvo após algumas semanas de uso aparentemente regular

Amarelo: alinhar em breve

- ou quando a sessão sugere piora progressiva apesar de adesão referida
- pode valer comunicar o psiquiatra para atualização do quadro clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Episódio de desmaio
- quase desmaio
- queda súbita ou relato de palpitações importantes associado a mal-estar durante a sessão ou nas horas anteriores.: Interromper o foco psicoterápico
- acionar avaliação médica no mesmo dia e considerar emergência conforme o estado clínico
- Rigidez intensa
- febre
- confusão acentuada ou rebaixamento importante do estado geral aparecendo junto de piora rápida do funcionamento.: Tratar como situação médica urgente
- acionar rede de apoio e encaminhar para avaliação imediata
- Ideias de morte ou autoagressão emergindo em contexto de piora rápida
- confusão
- agitação ou sofrimento persecutório crescente.: Fazer manejo de risco na própria sessão e acionar psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário no mesmo dia

Frase clínica

O foco clínico é distinguir contenção terapêutica de sedação e embotamento que empobrecem presença, adesão e leitura do quadro em sessão.

073 DECANOATO DE HALOPERIDOL

Substância: Decanoato de Haloperidol.

Nomes Comerciais: Halo Decanoato, Decan Haloper, Haldol
Decanoato

Uso comum

- O decanoato de haloperidol é um antipsicótico de ação prolongada, geralmente usado na manutenção de quadros psicóticos crônicos e, em alguns casos, quando há dificuldade de adesão ao uso diário. No consultório, o foco costuma ser menos a resposta aguda e mais o padrão ao longo de semanas: após cada aplicação pode haver períodos de maior lentificação, rigidez subjetiva ou inquietação, e a leitura clínica depende de comparar a sessão atual com a linha de base e com a proximidade da última dose. Mudanças graduais em 2 a 8 semanas podem refletir estabilização do quadro, mas também efeitos que o paciente tolera em silêncio para não perder o tratamento.

O paciente pode relatar

- **"Inquietação corporal:** Alguns pacientes chegam mais agitados no corpo do que no discurso: mudam de posição, balançam pernas, levantam e sentam, descrevendo um mal-estar difícil de nomear. Na sessão, isso pode ser confundido com ansiedade habitual, tensão situacional ou piora paranoide, especialmente se o conteúdo verbal não acompanha a intensidade motora. Vale observar se a inquietação aparece como necessidade física de se mover, se piora em certos períodos após a aplicação e se destoa do padrão prévio do paciente.

Lentificação e rigidez: Pode surgir um funcionamento mais travado, com fala menos espontânea, redução de gestos, expressão facial empobrecida e sensação de corpo endurecido ou pesado. Esse quadro pode parecer depressão, desmotivação ou retraimento defensivo, mas às vezes o paciente descreve que quer falar e não consegue acompanhar o próprio ritmo. A discriminação clínica depende de comparar acesso afetivo, velocidade psicomotora e iniciativa com a baseline, sem assumir que toda redução de intensidade seja melhora da desorganização.

Embotamento afetivo: Em parte dos pacientes, a sessão fica mais plana: menos variação emocional, menor ressonância afetiva e respostas mais econômicas, mesmo sem sofrimento subjetivo claramente nomeado. Isso pode ser lido como estabilização de sintomas positivos, esgotamento após crise ou efeito do tratamento sobre a expressividade. Ajuda observar se houve ganho de organização com perda de vitalidade, se o paciente percebe estranhamento em relação a si mesmo e se familiares notam alguém mais apagado do que propriamente melhor.

Adesão e intervalo: Como se trata de formulação de depósito, a adesão irregular nem sempre aparece como esquecimento diário, mas como atraso em aplicação, interrupção silenciosa ou comparecimento ambivalente ao serviço. Na terapia, isso pode emergir como oscilação entre sessões mais organizadas e outras com maior desconfiança, irritabilidade ou confusão sobre o próprio tratamento. Também vale considerar que o paciente pode minimizar desconfortos físicos e subjetivos por medo de internação, de crítica familiar ou de perder autonomia.

Cognição e iniciativa: Atenção mais lenta, dificuldade para sustentar raciocínio e menor iniciativa podem aparecer tanto como traço residual do transtorno quanto como efeito percebido no período de manutenção. Em sessão, isso se traduz em respostas concretas, menor elaboração e necessidade de mais tempo para acessar experiências internas. A leitura fica mais precisa quando o terapeuta diferencia déficit estável de mudança recente, e quando considera sono, uso de outras medicações sedativas e empobrecimento secundário ao próprio curso da doença.

Sinais físicos visíveis: Tremor fino, rigidez ao caminhar, postura endurecida, salivação aumentada ou expressão facial muito fixa podem aparecer antes de o paciente nomear incômodo. Esses sinais podem ser discretos e facilmente atribuídos a ansiedade, idade, condição neurológica prévia ou cansaço. Quando surgem de modo novo ou mais intenso, especialmente junto de sofrimento, vergonha ou evitação social, costumam ter valor clínico maior do que o paciente espontaneamente reconhece."

O que observar em sessão

- **Inquietação corporal:** Alguns pacientes chegam mais agitados no corpo do que no discurso: mudam de posição, balançam pernas, levantam e sentam, descrevendo um mal-estar difícil de nomear. Na sessão, isso pode ser confundido com ansiedade habitual, tensão situacional ou piora paranoide, especialmente se o conteúdo verbal não acompanha a intensidade motora. Vale observar se a inquietação aparece como necessidade física de se mover, se piora em certos períodos após a aplicação e se destoa do padrão prévio do paciente.

Lentificação e rigidez: Pode surgir um funcionamento mais travado, com fala menos espontânea, redução de gestos, expressão facial empobrecida e sensação de corpo endurecido ou pesado. Esse quadro pode parecer depressão, desmotivação ou retraimento defensivo, mas às vezes o paciente descreve que quer falar e não consegue acompanhar o próprio ritmo. A discriminação clínica depende de comparar acesso afetivo, velocidade psicomotora e iniciativa com a baseline, sem assumir que toda redução de intensidade seja melhora da desorganização.

Embotamento afetivo: Em parte dos pacientes, a sessão fica mais plana: menos variação emocional, menor ressonância afetiva e respostas mais econômicas, mesmo sem sofrimento subjetivo claramente nomeado. Isso pode ser lido como estabilização de sintomas positivos, esgotamento após crise ou efeito do tratamento sobre a expressividade. Ajuda observar se houve ganho de organização com perda de vitalidade, se o paciente percebe estranhamento em relação a si mesmo e se familiares notam alguém "mais apagado" do que propriamente melhor.

Adesão e intervalo: Como se trata de formulação de depósito, a adesão irregular nem sempre aparece como esquecimento diário, mas como atraso em aplicação, interrupção silenciosa ou comparecimento ambivalente ao serviço. Na terapia, isso pode emergir como oscilação entre sessões mais organizadas e outras com maior desconfiança, irritabilidade ou confusão sobre o próprio tratamento. Também vale considerar que o paciente pode minimizar desconfortos físicos e subjetivos por medo de internação, de crítica familiar ou de perder autonomia.

Cognição e iniciativa: Atenção mais lenta, dificuldade para sustentar raciocínio e menor iniciativa podem aparecer tanto como traço residual do transtorno quanto como efeito percebido no período de manutenção. Em sessão, isso se traduz em respostas concretas, menor elaboração e necessidade de mais tempo para acessar experiências internas. A leitura fica mais precisa quando o terapeuta diferencia déficit estável de mudança recente, e quando considera sono, uso de outras medicações sedativas e empobrecimento secundário ao próprio curso da doença.

Sinais físicos visíveis: Tremor fino, rigidez ao caminhar, postura endurecida, salivação aumentada ou expressão facial muito fixa podem aparecer antes de o paciente nomear incômodo. Esses sinais podem ser discretos e facilmente atribuídos a ansiedade, idade, condição neurológica prévia ou cansaço. Quando surgem de modo novo ou mais intenso, especialmente junto de sofrimento, vergonha ou evitação social, costumam ter valor clínico maior do que o paciente espontaneamente reconhece.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O decanoato de haloperidol é um antipsicótico de ação prolongada, geralmente usado na manutenção de quadros psicóticos crônicos e, em alguns casos, quando há dificuldade de adesão ao uso diário. No consultório, o foco costuma ser menos a resposta aguda e mais o padrão ao longo de semanas: após cada aplicação pode haver períodos de maior lentificação, rigidez subjetiva ou inquietação, e a leitura clínica depende de comparar a sessão atual com a linha de base e com a proximidade da última dose. Mudanças graduais em 2 a 8 semanas podem refletir estabilização do quadro, mas também efeitos que o paciente tolera em silêncio para não perder o tratamento.

Perguntas úteis

- "Quando você fica andando, mexendo as pernas ou sem conseguir se acomodar, isso parece vir de preocupação na cabeça ou de um incômodo físico que melhora só quando você se move? , Essa sensação de estar mais travado ou mais lento vem junto com tristeza e desesperança, ou você se percebe sem conseguir acompanhar o corpo e a fala mesmo querendo participar? , Entre uma aplicação e outra, você nota que há períodos em que fica mais pesado, mais inquieto ou mais organizado? Em que momento do intervalo isso costuma acontecer? , Quando você parece mais apagado, isso vem com alívio dos pensamentos que antes te confundiam ou com sensação de estar menos você, menos vivo, menos capaz de sentir? , Nas últimas semanas, houve alguma aplicação adiada, faltada ou feita com muita resistência, mesmo que você tenha preferido não comentar isso com ninguém? , Essas dificuldades de atenção e iniciativa são parecidas com o seu jeito habitual desde antes, ou você percebe uma mudança mais recente no seu ritmo para pensar e começar as coisas?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta inquietação motora persistente que interfere na permanência em sessão ou aumenta muito o sofrimento
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar ansiedade do quadro de um efeito extrapiramidal subjetivamente intolerável
- Quando surgem rigidez
- tremor
- marcha mais endurecida ou lentificação nova em relação à baseline
- pode valer comunicar o médico assistente para registrar a mudança funcional e o impacto no cotidiano
- Quando o paciente relata aplicações atrasadas
- interrupção silenciosa ou forte ambivalência em seguir o tratamento
- pode valer contato com o psiquiatra porque a oscilação clínica pode estar sendo lida apenas como evolução do quadro
- Quando há embotamento importante
- com perda de iniciativa e empobrecimento afetivo que comprometem vínculo
- trabalho ou autocuidado

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico para discutir se a mudança acompanha estabilização ou se está pesando no funcionamento
- Quando
- após algumas semanas de manutenção
- não se observa ganho de organização ou há recrudescimento de desconfiança
- desorganização ou alucinações
- pode valer comunicar o psiquiatra para revisão da leitura clínica e da adesão

Vermelho: tratar como urgência

- Febre ou sensação de estar muito quente
- confusão importante
- rigidez acentuada e piora rápida do estado geral durante ou logo antes da sessão.: Tratar como urgência clínica
- acionar avaliação médica no mesmo dia e recorrer à emergência se não houver retaguarda imediata
- Retorno marcado de desorganização
- intensa desconfiança
- vozes ameaçadoras ou agitação com perda de juízo crítico
- sobretudo após atraso de aplicação.: Avaliar risco imediato
- acionar psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhar para emergência se houver impossibilidade de manejo seguro
- Ideias de morte
- autoagressão ou risco dirigido a terceiros em contexto de psicose
- comando alucinatório ou grande desorganização.: Fazer manejo de crise na hora
- mobilizar rede de apoio e avaliação de urgência no mesmo dia

Frase clínica

No acompanhamento do haloperidol decanoato, a chave é distinguir estabilização de empobrecimento, inquietação extrapiramidal e oscilação ligada ao intervalo das aplicações.

074 DICLORIDRATO DE FLUFENAZINA

Substância: Dicloridrato de Flufenazina.

Nomes Comerciais: Flufenan

Uso comum

- O dicloridrato de flufenazina é um antipsicótico típico que costuma aparecer no consultório em pacientes com quadros psicóticos crônicos, às vezes em uso prolongado e com histórico de adesão irregular. Nas primeiras semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto sedação, lentificação, inquietação corporal e mudanças no acesso afetivo; ao longo de 4 a 8 semanas, vale observar se há redução de desorganização e agitação sem custo subjetivo excessivo em apatia ou rigidez. Em uso contínuo, o ponto central na sessão é diferenciar estabilização clínica de empobrecimento expressivo, efeitos motores e abandono silencioso por desconforto.

O paciente pode relatar

- **"Expressão afetiva:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter menos reatividade, fala mais econômica e menor variação emocional. Isso pode acompanhar melhora de agitação, persecutoriedade ou desorganização, mas também pode ser vivido como embotamento, distanciamento ou perda de espontaneidade. A leitura fica confusa quando o quadro de base já incluía retraimento, sintomas negativos ou esgotamento após crise, por isso ajuda comparar com a baseline do paciente e com o quanto ele ainda consegue se implicar afetivamente no vínculo e na própria narrativa.

Sedação e lentificação: Sonolência, redução do ritmo de fala, maior latência para responder e aparência de cansaço podem aparecer com destaque no início ou após mudanças recentes no tratamento referidas pelo paciente. Na sessão, isso pode se parecer com piora depressiva, desmotivação ou simples privação de sono. A discriminação costuma depender de perguntar pelo padrão ao longo do dia, pelo contraste com o funcionamento prévio e por outras medicações ou substâncias que também possam estar contribuindo.

Inquietação corporal: Alguns pacientes chegam mais incapazes de permanecer sentados, mudam de posição repetidamente ou descrevem um desconforto interno difícil de nomear. Na clínica, isso pode ser confundido com ansiedade habitual, tensão por temas da sessão ou agitação do próprio quadro psicótico. O ponto útil é notar se a inquietação parece mais corporal do que ideativa, se surgiu após início ou retomada do medicamento e se o paciente a associa a vontade de interromper o tratamento sem ter dito isso ao médico.

Rigidez e movimentos: Aparecimento de rigidez, face menos móvel, marcha mais travada, tremor fino ou redução de gesticulação pode alterar bastante a presença do paciente em sessão. Esses sinais podem ser lidos apressadamente como retraimento, envelhecimento, medo ou desinvestimento, quando às vezes o componente motor é o que mais pesa. Também vale lembrar que sintomas neurológicos prévios, ansiedade intensa e outras medicações podem confundir a observação, então o registro longitudinal costuma ser mais útil do que uma impressão isolada.

Adesão silenciosa: Com flufenazina, o abandono nem sempre aparece como decisão explícita; às vezes surge como faltas, oscilação brusca entre sessões mais organizadas e outras mais descompensadas, ou narrativa vaga sobre uso "mais ou menos". O paciente pode omitir desconfortos por receio de perder controle dos sintomas, por pouca elaboração sobre o tratamento ou por relação ambivalente com a equipe. Na sessão, interessa menos confirmar detalhes técnicos e mais mapear o que ele efetivamente tem conseguido sustentar, o que o faz evitar o tema e quais efeitos subjetivos podem estar minando a continuidade.

Resposta psicótica: Quando há benefício, tende a aparecer menos urgência persecutória, menor desorganização e maior possibilidade de sustentar conversa com encadeamento. Isso não significa remissão completa, e a melhora pode coexistir com apatia, desconfiança residual ou prejuízo cognitivo. Eventos de vida, uso de substâncias, privação de sono e adesão irregular podem produzir oscilações que parecem "falha do remédio", então a sessão precisa situar temporalmente o que mudou e em que contexto."

O que observar em sessão

- **Expressão afetiva:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter menos reatividade, fala mais econômica e menor variação emocional. Isso pode acompanhar melhora de agitação, persecutoriedade ou desorganização, mas também pode ser vivido como embotamento, distanciamento ou perda de espontaneidade. A leitura fica confusa quando o quadro de base já incluía retraimento, sintomas negativos ou esgotamento após crise, por isso ajuda comparar com a baseline do paciente e com o quanto ele ainda consegue se implicar afetivamente no vínculo e na própria narrativa.

Sedação e lentificação: Sonolência, redução do ritmo de fala, maior latência para responder e aparência de cansaço podem aparecer com destaque no início ou após mudanças recentes no tratamento referidas pelo paciente. Na sessão, isso pode se parecer com piora depressiva, desmotivação ou simples privação de sono. A discriminação costuma depender de perguntar pelo padrão ao longo do dia, pelo contraste com o funcionamento prévio e por outras medicações ou substâncias que também possam estar contribuindo.

Inquietação corporal: Alguns pacientes chegam mais incapazes de permanecer sentados, mudam de posição repetidamente ou descrevem um desconforto interno difícil de nomear. Na clínica, isso pode ser confundido com ansiedade habitual, tensão por temas da sessão ou agitação do próprio quadro psicótico. O ponto útil é notar se a inquietação parece mais corporal do que ideativa, se surgiu após início ou retomada do medicamento e se o paciente a associa a vontade de interromper o tratamento sem ter dito isso ao médico.

Rigidez e movimentos: Aparecimento de rigidez, face menos móvel, marcha mais travada, tremor fino ou redução de gesticulação pode alterar bastante a presença do paciente em sessão. Esses sinais podem ser lidos apressadamente como retraimento, envelhecimento, medo ou desinvestimento, quando às vezes o componente motor é o que mais pesa. Também vale lembrar que sintomas neurológicos prévios, ansiedade intensa e outras medicações podem confundir a observação, então o registro longitudinal costuma ser mais útil do que uma impressão isolada.

Adesão silenciosa: Com flufenazina, o abandono nem sempre aparece como decisão explícita; às vezes surge como faltas, oscilação brusca entre sessões mais organizadas e outras mais descompensadas, ou narrativa vaga sobre uso “mais ou menos”. O paciente pode omitir desconfortos por receio de perder controle dos sintomas, por pouca elaboração sobre o tratamento ou por relação ambivalente com a equipe. Na sessão, interessa menos confirmar detalhes técnicos e mais mapear o que ele efetivamente tem conseguido sustentar, o que o faz evitar o tema e quais efeitos subjetivos podem estar minando a continuidade.

Resposta psicótica: Quando há benefício, tende a aparecer menos urgência persecutória, menor desorganização e maior possibilidade de sustentar conversa com encadeamento. Isso não significa remissão completa, e a melhora pode coexistir com apatia, desconfiança residual ou prejuízo cognitivo. Eventos de vida, uso de substâncias, privação de sono e adesão irregular podem produzir oscilações que parecem “falha do remédio”, então a sessão precisa situar temporalmente o que mudou e em que contexto.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O dicloridrato de flufenazina é um antipsicótico típico que costuma aparecer no consultório em pacientes com quadros psicóticos crônicos, às vezes em uso prolongado e com histórico de adesão irregular. Nas primeiras semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto sedação, lentificação, inquietação corporal e mudanças no acesso afetivo; ao longo de 4 a 8 semanas, vale observar se há redução de desorganização e agitação sem custo subjetivo excessivo em apatia ou rigidez. Em uso contínuo, o ponto central na sessão é diferenciar estabilização clínica de empobrecimento expressivo, efeitos motores e abandono silencioso por desconforto.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais travado ou sonolento, isso vem junto de tristeza e desesperança ou parece mais um corpo pesado e lento, mesmo sem piora clara do humor? , Essa inquietação que aparece em você parece vir de pensamentos acelerados e preocupação, ou é mais uma sensação física de não conseguir ficar parado mesmo quando a cabeça não está tão ansiosa? , Você percebe que está menos sofrendo com certas ideias e medos, ou sente que ficou mais indiferente a tudo, inclusive ao que antes importava para você? , Nos dias em que você usa de forma diferente do habitual ou acaba falhando, o que muda primeiro: seu corpo, seu sono, sua disposição para vir à sessão ou a intensidade das ideias estranhas e da desconfiança? , Quando sua fala fica mais curta ou você se afasta mais, isso parece escolha para se proteger, dificuldade de organizar o pensamento ou sensação de estar mais travado por dentro e por fora? , Esses movimentos, rigidez ou tremores aparecem o tempo todo ou você nota relação com certos horários do dia e com momentos em que o desconforto fica tão grande que dá vontade de largar o tratamento?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a mostrar rigidez
- tremor
- marcha travada ou inquietação corporal que interferem na sessão e na rotina
- pode valer alinhar com o psiquiatra para avaliar impacto funcional e risco de abandono silencioso
- Quando surge apatia marcada
- empobrecimento expressivo ou queda importante de iniciativa após início recente ou retomada do uso
- pode valer comunicar o médico para diferenciar estabilização do quadro de um custo subjetivo relevante do tratamento
- Quando o paciente relata uso irregular
- interrupções por conta própria ou omissão de desconfortos por medo ou ambivalência
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar a adesão real e prevenir descompensação
- Quando
- após algumas semanas

Amarelo: alinhar em breve

- persistem desorganização importante
- persecutoriedade ou agitação sem melhora perceptível no funcionamento
- pode valer contato com o médico assistente para compartilhar a evolução observada em sessão
- Quando aparecem movimentos involuntários persistentes na face
- língua ou membros
- mesmo sem sofrimento verbalizado
- pode valer comunicar o psiquiatra porque o paciente às vezes não reconhece a relevância clínica desses sinais

Vermelho: tratar como urgência

- Febre ou sensação de estar muito quente
- confusão importante
- rigidez acentuada e piora rápida do estado geral aparecendo juntos na sessão ou no relato muito recente.: Tratar como urgência clínica no mesmo dia
- acionando psiquiatra
- rede de apoio e avaliação médica imediata conforme o contexto
- Retorno rápido de intensa desorganização
- medo persecutório ou agitação com perda importante de juízo crítico
- sobretudo se houver relato de interrupção do uso.: Avaliar segurança imediata
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia; se houver risco para si ou terceiros
- encaminhar para avaliação de urgência
- Movimentos involuntários persistentes e evidentes de face
- língua ou membros que surgem ou se intensificam de modo claro.: Registrar de forma descritiva e buscar contato médico no mesmo dia ou o mais breve possível
- pela necessidade de avaliação rápida

Frase clínica

O foco é distinguir contenção da psicose de custo motor, sedação e empobrecimento subjetivo que podem minar a adesão.

075 DICLORIDRATO DE TRIFLUOPERAZINA

Substância: Dicloridrato de Trifluoperazina.

Nomes Comerciais: Stelazine

Uso comum

- O dicloridrato de trifluoperazina é um antipsicótico típico que pode aparecer em pacientes com quadros psicóticos, agitação importante, ansiedade grave em contextos específicos ou uso mais antigo mantido ao longo do tempo. No consultório, a leitura costuma depender menos de melhora subjetiva rápida e mais de mudanças graduais ao longo de dias a poucas semanas, com atenção redobrada no início e após retomadas irregulares, quando efeitos motores e sedação podem ficar mais visíveis. O ponto central na sessão é diferenciar lentificação, inquietação corporal, embotamento e rigidez do curso do transtorno de base, de sofrimento situacional ou de adesão oscilante.

O paciente pode relatar

- **"Inquietação motora:** Alguns pacientes chegam mais incapazes de permanecer sentados, mudam de posição o tempo todo ou descrevem um desconforto corporal difícil de nomear, às vezes vivido como ansiedade intensa. Na sessão, isso pode ser confundido com piora ansiosa habitual, ativação por estresse externo ou aumento de tensão ligado ao próprio conteúdo trabalhado. Vale observar se a inquietação parece mais corporal do que ideativa, se surgiu perto do início do uso ou de mudanças na regularidade, e se destoa da linha de base do paciente.

Lentificação e sedação: Pode aparecer fala mais lenta, redução da espontaneidade, sonolência, menor iniciativa associativa e queda do rendimento na sessão. Esse padrão pode se confundir com agravamento depressivo, exaustão por insônia prévia, uso concomitante de outras medicações sedativas ou sobrecarga de vida. A discriminação clínica ganha precisão quando o terapeuta compara com o baseline do paciente e com o horário em que ele costuma tomar a medicação, sem assumir causalidade automática.

Rigidez expressiva: Em parte dos pacientes, a sessão fica marcada por menor mobilidade facial, voz menos modulada e acesso afetivo mais empobrecido, o que pode ser lido apressadamente como retraimento defensivo ou piora negativa do quadro. Também pode haver redução genuína da desorganização ou da agitação, produzindo uma aparência mais contida que não equivale necessariamente a elaboração psíquica ampliada. O trabalho clínico pede distinguir contenção útil de empobrecimento expressivo que interfere no vínculo e na capacidade de simbolização.

Cognição e contato: Atenção mais oscilante, dificuldade de acompanhar encadeamentos e sensação de pensamento mais travado podem aparecer no relato ou na observação direta. Isso pode decorrer do transtorno de base, de sedação, de privação de sono, de uso irregular ou de outras substâncias, e não convém atribuir tudo ao medicamento. Na prática, importa notar se houve mudança nítida em relação ao funcionamento habitual e se o paciente percebe essa alteração como alívio da confusão prévia ou como perda de clareza.

Adesão silenciosa: Com antipsicóticos mais antigos, não é raro que o paciente reduza, interrompa ou retome por conta própria sem trazer isso espontaneamente, sobretudo quando sente desconforto corporal, rigidez, sonolência ou sensação de estar apagado. Na sessão, a pista pode ser uma oscilação abrupta entre dias muito contidos e outros mais agitados, ou uma narrativa vaga sobre tomar quando dá. Diferenciar recaída do quadro, efeito adverso e adesão irregular costuma depender de perguntas concretas sobre continuidade real do uso e sobre o que motivou eventuais falhas.

Sinais físicos visíveis: Tremor fino, rigidez, marcha mais endurecida, salivação aumentada ou dificuldade subjetiva para engolir podem aparecer de modo discreto no encontro clínico. Esses sinais podem ser confundidos com ansiedade somatizada, envelhecimento, condição neurológica prévia ou tensão muscular associada ao setting. Quando surgem junto de mudança recente no padrão da medicação ou de piora funcional evidente, ganham peso como achados a registrar e eventualmente comunicar ao médico assistente."

O que observar em sessão

- **Inquietação motora:** Alguns pacientes chegam mais incapazes de permanecer sentados, mudam de posição o tempo todo ou descrevem um desconforto corporal difícil de nomear, às vezes vivido como ansiedade intensa. Na sessão, isso pode ser confundido com piora ansiosa habitual, ativação por estresse externo ou aumento de tensão ligado ao próprio conteúdo trabalhado. Vale observar se a inquietação parece mais corporal do que ideativa, se surgiu perto do início do uso ou de mudanças na regularidade, e se destoa da linha de base do paciente.

Lentificação e sedação: Pode aparecer fala mais lenta, redução da espontaneidade, sonolência, menor iniciativa associativa e queda do rendimento na sessão. Esse padrão pode se confundir com agravamento depressivo, exaustão por insônia prévia, uso concomitante de outras medicações sedativas ou sobrecarga de vida. A discriminação clínica ganha precisão quando o terapeuta compara com o baseline do paciente e com o horário em que ele costuma tomar a medicação, sem assumir causalidade automática.

Rigidez expressiva: Em parte dos pacientes, a sessão fica marcada por menor mobilidade facial, voz menos modulada e acesso afetivo mais empobrecido, o que pode ser lido apressadamente como retraimento defensivo ou piora negativa do quadro. Também pode haver redução genuína da desorganização ou da agitação, produzindo uma aparência mais contida que não equivale necessariamente a elaboração psíquica ampliada. O trabalho clínico pede distinguir contenção útil de empobrecimento expressivo que interfere no vínculo e na capacidade de simbolização.

Cognição e contato: Atenção mais oscilante, dificuldade de acompanhar encadeamentos e sensação de pensamento mais travado podem aparecer no relato ou na observação direta. Isso pode decorrer do transtorno de base, de sedação, de privação de sono, de uso irregular ou de outras substâncias, e não convém atribuir tudo ao medicamento. Na prática, importa notar se houve mudança nítida em relação ao funcionamento habitual e se o paciente percebe essa alteração como alívio da confusão prévia ou como perda de clareza.

Adesão silenciosa: Com antipsicóticos mais antigos, não é raro que o paciente reduza, interrompa ou retome por conta própria sem trazer isso espontaneamente, sobretudo quando sente desconforto corporal, rigidez, sonolência ou sensação de estar "apagado". Na sessão, a pista pode ser uma oscilação abrupta entre dias muito contidos e outros mais agitados, ou uma narrativa vaga sobre tomar "quando dá". Diferenciar recaída do quadro, efeito adverso e adesão irregular costuma depender de perguntas concretas sobre continuidade real do uso e sobre o que motivou eventuais falhas.

Sinais físicos visíveis: Tremor fino, rigidez, marcha mais endurecida, salivação aumentada ou dificuldade subjetiva para engolir podem aparecer de modo discreto no encontro clínico. Esses sinais podem ser confundidos com ansiedade somatizada, envelhecimento, condição neurológica prévia ou tensão muscular associada ao setting. Quando surgem junto de mudança recente no padrão da medicação ou de piora funcional evidente, ganham peso como achados a registrar e eventualmente comunicar ao médico assistente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O dicloridrato de trifluoperazina é um antipsicótico típico que pode aparecer em pacientes com quadros psicóticos, agitação importante, ansiedade grave em contextos específicos ou uso mais antigo mantido ao longo do tempo. No consultório, a leitura costuma depender menos de melhora subjetiva rápida e mais de mudanças graduais ao longo de dias a poucas semanas, com atenção redobrada no início e após retomadas irregulares, quando efeitos motores e sedação podem ficar mais visíveis. O ponto central na sessão é diferenciar lentificação, inquietação corporal, embotamento e rigidez do curso do transtorno de base, de sofrimento situacional ou de adesão oscilante.

Perguntas úteis

- "Quando essa agitação aparece, ela vem mais como preocupação na cabeça ou como uma sensação física de não conseguir ficar parado? , Você se percebe mais sonolento e travado por dentro, ou mais desanimado e sem vontade mesmo quando o corpo está desperto? , Essa redução da sua expressão parece um alívio da confusão e da agitação, ou uma sensação de estar mais apagado e menos você mesmo? , Nos dias em que você fica mais lento ou mais inquieto, isso coincide com algum padrão de uso irregular, esquecimento ou retomada depois de parar? , Essa dificuldade de pensar e acompanhar a conversa parece continuação do que já acontecia antes, ou surgiu como uma mudança nova depois que o tratamento entrou na rotina? , Quando o corpo fica duro, trêmulo ou estranho, isso melhora ao longo do dia, piora após tomar a medicação ou não segue nenhum padrão claro para você?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a evitar o uso
- omitir interrupções ou relatar retomadas irregulares por desconforto corporal ou sensação de estar "apagado"
- pode valer alinhar com o psiquiatra para reduzir risco de abandono silencioso e confusão diagnóstica na sessão
- Quando surgem inquietação corporal intensa
- incapacidade de permanecer sentado ou sofrimento importante que o paciente nomeia como ansiedade nova
- pode valer alinhar com o psiquiatra para discriminar efeito do tratamento de piora do quadro
- Quando a sessão mostra rigidez
- tremor
- marcha endurecida ou dificuldade para engolir que não faziam parte do baseline
- pode valer comunicar o médico assistente para avaliação clínica oportuna
- Quando há embotamento expressivo importante
- queda de iniciativa e prejuízo funcional que dificultam o trabalho terapêutico
- pode valer alinhar com o psiquiatra para compartilhar a mudança observada
- Quando
- após algumas semanas de uso regular

Amarelo: alinhar em breve

- não se observa redução da desorganização
- da agitação ou do sofrimento que motivou o tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente para atualização do quadro clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Febre
- confusão importante
- rigidez intensa e piora rápida do estado geral aparecendo juntos ou em sequência próxima.: Acionar avaliação médica no mesmo dia; se houver comprometimento importante do estado geral
- orientar busca imediata de emergência e acionar rede de apoio quando necessário
- Dificuldade relevante para engolir
- falar ou respirar
- ou contrações musculares intensas e súbitas visíveis na sessão.: Interromper o manejo habitual da sessão e buscar avaliação médica imediata
- com apoio da rede e emergência se necessário
- Retorno de desorganização grave
- ideias persecutórias muito intensas ou agitação que compromete juízo de realidade e segurança
- sobretudo após interrupção do uso.: Fazer manejo de crise
- avaliar risco imediato e acionar psiquiatra
- rede de apoio e emergência conforme a gravidade

Frase clínica

O foco clínico é separar contenção terapêutica de lentificação, inquietação motora e rigidez que podem reorganizar a aparência da sessão sem melhorar o sofrimento.

076 DICLORIDRATO DE ZUCLOPENTIXOL

Substância: Dicloridrato de Zuclopentixol.

Nomes Comerciais: Clopixol

Uso comum

- O dicloridrato de zuclopentixol é um antipsicótico típico que costuma aparecer no consultório em pacientes com quadros psicóticos, agitação importante ou desorganização, às vezes em fases de maior instabilidade do humor. Nas primeiras semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto sedação, lentificação, inquietação corporal e mudanças no acesso afetivo; ao longo de 2 a 6 semanas, pode ficar mais claro se houve redução da desorganização sem custo excessivo em iniciativa, vínculo e participação na sessão. O ponto central é não confundir melhora da agitação com empobrecimento global do contato, nem inquietação medicamentosa com ansiedade habitual ou agravamento do quadro.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com fala menos espontânea, maior latência para responder, sonolência visível ou dificuldade de sustentar elaboração. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento no processo ou resistência, quando às vezes coincide temporalmente com início do tratamento ou mudança recente no uso. Vale comparar com a linha de base: se a desorganização diminui, mas o paciente fica excessivamente apagado, a melhora pode estar vindo acompanhada de um custo clínico relevante para o trabalho terapêutico.

Inquietação corporal: Zuclopentixol pode vir acompanhado de inquietação motora subjetivamente penosa: o paciente muda de posição o tempo todo, balança pernas, levanta e senta, ou descreve não conseguir ficar parado. Na sessão, isso pode se confundir com ansiedade basal, angústia diante de temas sensíveis ou ativação do próprio quadro. A discriminação depende de observar se a inquietação é mais corporal do que ideativa, se piora em repouso e se surgiu em proximidade temporal com o tratamento, sobretudo quando o conteúdo verbal não acompanha a intensidade do movimento.

Acesso afetivo: À medida que a agitação ou a desorganização cedem, pode haver também redução da expressividade, do alcance emocional e da espontaneidade associativa. O terapeuta pode notar contato mais empobrecido, respostas concretas e menor ressonância afetiva, o que às vezes parece estabilização e, em outras, embotamento que limita elaboração. Também entram como confundidores sintomas negativos do quadro de base, retraimento defensivo e uso irregular, que pode produzir sessões muito diferentes entre si.

Cognição e participação: Alguns pacientes passam a relatar pensamento mais organizado, enquanto outros parecem mais lentos, com dificuldade de concentração, memória de curto prazo menos acessível e menor capacidade de acompanhar intervenções mais complexas. Na prática, isso pode alterar o enquadre: a sessão rende menos, há perda do fio narrativo e necessidade de intervenções mais simples. Nem sempre isso decorre do medicamento; privação de sono, uso de outras medicações sedativas, consumo de substâncias e flutuação do próprio quadro psicótico podem produzir apresentação semelhante.

Adesão e oscilação: Como efeitos subjetivamente incômodos podem aparecer cedo, não é raro surgirem uso irregular, esquecimentos seletivos ou interrupções não verbalizadas, especialmente quando o paciente valoriza apenas a redução da agitação e silencia o custo corporal. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação abrupta entre encontros, retorno de irritabilidade ou desorganização, ou narrativa vaga sobre como tem tomado a medicação. Diferenciar baixa adesão de piora espontânea do quadro exige perguntar por mudanças concretas no padrão diário e observar se as flutuações são rápidas demais para serem explicadas apenas por eventos de vida.

Sinais motores visíveis: Além da inquietação, podem aparecer rigidez, postura mais endurecida, redução do balanço dos braços, face menos móvel, fala mais presa ou queixa de corpo travado. Esses sinais, quando discretos, às vezes são lidos como tensão emocional, inibição social ou efeito do próprio sofrimento psíquico. O valor clínico está em notar mudança em relação ao habitual e registrar a combinação entre relato corporal e observação direta,

porque esse conjunto costuma ser mais útil do que uma interpretação isolada."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com fala menos espontânea, maior latência para responder, sonolência visível ou dificuldade de sustentar elaboração. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento no processo ou resistência, quando às vezes coincide temporalmente com início do tratamento ou mudança recente no uso. Vale comparar com a linha de base: se a desorganização diminui, mas o paciente fica excessivamente apagado, a melhora pode estar vindo acompanhada de um custo clínico relevante para o trabalho terapêutico.

Inquietação corporal: Zuclopentixol pode vir acompanhado de inquietação motora subjetivamente penosa: o paciente muda de posição o tempo todo, balança pernas, levanta e senta, ou descreve não conseguir ficar parado. Na sessão, isso pode se confundir com ansiedade basal, angústia diante de temas sensíveis ou ativação do próprio quadro. A discriminação depende de observar se a inquietação é mais corporal do que ideativa, se piora em repouso e se surgiu em proximidade temporal com o tratamento, sobretudo quando o conteúdo verbal não acompanha a intensidade do movimento.

Acesso afetivo: À medida que a agitação ou a desorganização cedem, pode haver também redução da expressividade, do alcance emocional e da espontaneidade associativa. O terapeuta pode notar contato mais empobrecido, respostas concretas e menor ressonância afetiva, o que às vezes parece estabilização e, em outras, embotamento que limita elaboração. Também entram como confundidores sintomas negativos do quadro de base, retraimento defensivo e uso irregular, que pode produzir sessões muito diferentes entre si.

Cognição e participação: Alguns pacientes passam a relatar pensamento mais organizado, enquanto outros parecem mais lentos, com dificuldade de concentração, memória de curto prazo menos acessível e menor capacidade de acompanhar intervenções mais complexas. Na prática, isso pode alterar o enquadre: a sessão rende menos, há perda do fio narrativo e necessidade de intervenções mais simples. Nem sempre isso decorre do medicamento; privação de sono, uso de outras medicações sedativas, consumo de substâncias e flutuação do próprio quadro psicótico podem produzir apresentação semelhante.

Adesão e oscilação: Como efeitos subjetivamente incômodos podem aparecer cedo, não é raro surgirem uso irregular, esquecimentos seletivos ou interrupções não verbalizadas, especialmente quando o paciente valoriza apenas a redução da agitação e silencia o custo corporal. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação abrupta entre encontros, retorno de irritabilidade ou desorganização, ou narrativa vaga sobre como tem tomado a medicação. Diferenciar baixa adesão de piora espontânea do quadro exige perguntar por mudanças concretas no padrão diário e observar se as flutuações são rápidas demais para serem explicadas apenas por eventos de vida.

Sinais motores visíveis: Além da inquietação, podem aparecer rigidez, postura mais endurecida, redução do balanço dos braços, face menos móvel, fala mais presa ou queixa de corpo travado. Esses sinais, quando discretos, às vezes são lidos como tensão emocional, inibição social ou efeito do próprio sofrimento psíquico. O valor clínico está em notar mudança em relação ao habitual e registrar a combinação entre relato corporal e observação direta,

porque esse conjunto costuma ser mais útil do que uma interpretação isolada.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O dicloridrato de zuclopentixol é um antipsicótico típico que costuma aparecer no consultório em pacientes com quadros psicóticos, agitação importante ou desorganização, às vezes em fases de maior instabilidade do humor. Nas primeiras semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto sedação, lentificação, inquietação corporal e mudanças no acesso afetivo; ao longo de 2 a 6 semanas, pode ficar mais claro se houve redução da desorganização sem custo excessivo em iniciativa, vínculo e participação na sessão. O ponto central é não confundir melhora da agitação com empobrecimento global do contato, nem inquietação medicamentosa com ansiedade habitual ou agravamento do quadro.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais agitado por dentro, isso vem junto com pensamentos acelerados e preocupação, ou é mais uma sensação corporal de não conseguir ficar parado mesmo sem um motivo claro? , Essa lentidão que apareceu parece com tristeza e falta de vontade, ou você sente que até quer participar, mas o corpo e a fala não acompanham? , Desde que começou esse tratamento, você percebeu que ficou mais calmo de um jeito que ajuda a pensar melhor, ou mais apagado, distante e com menos acesso ao que sente? , Nos dias em que você parece diferente de uma sessão para outra, houve alguma mudança concreta em como tomou a medicação, no sono, no uso de álcool ou outras substâncias, ou isso oscilou sem um motivo identificável? , Quando seu corpo fica mais travado ou inquieto, isso melhora quando você está envolvido em algo ou continua mesmo em momentos neutros, como sentado em silêncio? , A dificuldade de concentração aparece junto com confusão do pensamento como antes, ou o pensamento está mais organizado e o problema é mais lentidão para acompanhar?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente fica nitidamente mais apagado
- sonolento ou lentificado a ponto de comprometer vínculo
- funcionalidade ou participação mínima na sessão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar o impacto clínico observado
- Quando surge inquietação corporal persistente
- desproporcional ao conteúdo emocional e descrita como muito penosa
- pode valer comunicar ao médico assistente para diferenciar ansiedade do quadro de um possível efeito do tratamento
- Quando aparecem rigidez
- travamento corporal
- fala mais presa ou mudança motora visível em relação à linha de base
- pode valer contato com o psiquiatra para registrar sinais observáveis relevantes
- Quando há oscilação importante entre sessões com suspeita de adesão irregular
- interrupção silenciosa ou uso muito inconsistente

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico para contextualizar a instabilidade clínica
- Quando
- após algumas semanas
- a agitação diminui mas o paciente permanece muito empobrecido no contato
- com pouca iniciativa e baixa capacidade de elaboração
- pode valer comunicação para discutir o balanço entre contenção e custo funcional
- Quando o paciente ou a família relatam piora recente de desorganização
- irritabilidade ou comportamento estranho após interrupções no uso
- pode valer informar o psiquiatra para situar a sequência temporal observada

Vermelho: tratar como urgência

- Febre referida ou observável
- confusão importante
- sudorese intensa e corpo muito rígido
- com piora rápida do estado geral.: Tratar como urgência clínica no mesmo dia
- acionando avaliação médica imediata e rede de apoio; emergência pode ser necessária
- Retorno acentuado de desorganização
- ideias persecutórias ou comportamento muito estranho com perda de juízo crítico e risco de exposição ou agressividade.: Fazer manejo de crise
- acionar psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e considerar encaminhamento para avaliação de urgência conforme o risco

Frase clínica

O foco é distinguir contenção da agitação de custo excessivo em vitalidade, contato e motricidade ao longo das primeiras semanas.

077 ENANTATO DE FLUFENAZINA

Substância: Enantato de Flufenazina.

Nomes Comerciais: Flufenan Depot

Uso comum

- Enantato de flufenazina é um antipsicótico de depósito, geralmente encontrado em quadros psicóticos crônicos ou quando há histórico de adesão irregular ao tratamento oral. No consultório, o ponto central não costuma ser “se tomou ou não tomou hoje”, mas como o paciente chega ao longo das semanas entre aplicações: mais organizado ou mais desconfiado, mais lentificado, rígido ou inquieto. Mudanças podem aparecer nos primeiros dias após a aplicação e também perto do fim do intervalo, quando alguns pacientes descrevem piora subjetiva ou retorno de sintomas. Vale acompanhar o padrão temporal da sessão, porque efeitos do medicamento, reemergência do quadro de base e uso irregular de outras medicações podem se confundir.

O paciente pode relatar

- **"Organização psíquica:** Em parte dos pacientes, a sessão mostra maior encadeamento do pensamento, menos intrusão delirante e melhor contato com a realidade ao longo do tratamento. Em outros momentos, podem reaparecer desconfiança, respostas tangenciais, empobrecimento do discurso ou maior dificuldade de sustentar o vínculo. A leitura clínica pede comparação com a baseline e com o momento do ciclo entre aplicações, porque piora do quadro, estresse ambiental e uso irregular de medicações associadas podem produzir apresentações semelhantes.

Rigidez e lentificação: Alguns pacientes chegam mais duros corporalmente, com menos gestualidade, fala mais lenta, face pouco móvel ou sensação de corpo pesado. Isso pode ser lido apressadamente como retraimento depressivo, desinvestimento ou resistência, quando às vezes o que predomina é uma alteração motora perceptível na sessão. Também convém considerar sintomas negativos, sedação por outras substâncias e cansaço acumulado antes de atribuir a mudança a um único fator.

Inquietação interna: Pode surgir um desconforto difícil de nomear, com necessidade de mudar de posição, balançar as pernas, levantar-se mais do que o habitual ou relatar que "não consegue ficar parado". Na sessão, isso pode se confundir com ansiedade habitual, agitação por conteúdo emocional ou aumento de tensão persecutória. O diferencial costuma ficar mais claro quando o paciente descreve a inquietação como corporal, pouco ligada a pensamentos específicos, e quando o padrão aparece de modo novo após início ou manutenção do esquema.

Embotamento e acesso afetivo: Há pacientes que parecem menos reativos, com afeto mais plano, menor espontaneidade e dificuldade de nomear nuances emocionais. Em alguns casos isso acompanha estabilização do quadro; em outros, empobrece a elaboração e dá a impressão de presença apenas formal na sessão. Vale discriminar se houve redução do sofrimento com preservação de interesse e vínculo, ou se o paciente passou a relatar uma vida emocional mais apagada, o que também pode favorecer abandono silencioso do tratamento.

Adesão e intervalo: Como se trata de formulação de longa ação, a adesão irregular pode ficar menos visível do que com medicação oral, mas ainda aparece na sessão por faltas a aplicações, adiamentos, recusa parcial do tratamento ou uso errático de remédios concomitantes. Às vezes o paciente relata que "fica pior" em determinado ponto do mês, e isso pode corresponder tanto a expectativa subjetiva quanto a oscilação clínica real. Observar a cronologia entre aplicação, mudança no funcionamento e comparecimento às sessões ajuda a não confundir descontinuidade de cuidado com recaída espontânea.

Sinais físicos visíveis: Tremor fino, salivação aumentada, marcha mais travada, postura enrijecida ou dificuldade para iniciar movimentos podem aparecer de forma discreta e serem percebidos antes de virarem queixa espontânea. Esses sinais podem interferir na autoestima, na disposição para sair de casa e na qualidade do encontro terapêutico, inclusive pela vergonha de estar sendo observado. Quando surgem de modo novo ou se intensificam, vale registrar concretamente o que foi visto, porque o paciente nem sempre leva esse tipo de mudança para a consulta médica."

O que observar em sessão

- **Organização psíquica:** Em parte dos pacientes, a sessão mostra maior encadeamento do pensamento, menos intrusão delirante e melhor contato com a realidade ao longo do tratamento. Em outros momentos, podem reaparecer desconfiança, respostas tangenciais, empobrecimento do discurso ou maior dificuldade de sustentar o vínculo. A leitura clínica pede comparação com a baseline e com o momento do ciclo entre aplicações, porque piora do quadro, estresse ambiental e uso irregular de medicações associadas podem produzir apresentações semelhantes.

Rigidez e lentificação: Alguns pacientes chegam mais duros corporalmente, com menos gestualidade, fala mais lenta, face pouco móvel ou sensação de corpo pesado. Isso pode ser lido apressadamente como retraimento depressivo, desinvestimento ou resistência, quando às vezes o que predomina é uma alteração motora perceptível na sessão. Também convém considerar sintomas negativos, sedação por outras substâncias e cansaço acumulado antes de atribuir a mudança a um único fator.

Inquietação interna: Pode surgir um desconforto difícil de nomear, com necessidade de mudar de posição, balançar as pernas, levantar-se mais do que o habitual ou relatar que “não consegue ficar parado”. Na sessão, isso pode se confundir com ansiedade habitual, agitação por conteúdo emocional ou aumento de tensão persecutória. O diferencial costuma ficar mais claro quando o paciente descreve a inquietação como corporal, pouco ligada a pensamentos específicos, e quando o padrão aparece de modo novo após início ou manutenção do esquema.

Embotamento e acesso afetivo: Há pacientes que parecem menos reativos, com afeto mais plano, menor espontaneidade e dificuldade de nomear nuances emocionais. Em alguns casos isso acompanha estabilização do quadro; em outros, empobrece a elaboração e dá a impressão de presença apenas formal na sessão. Vale discriminar se houve redução do sofrimento com preservação de interesse e vínculo, ou se o paciente passou a relatar uma vida emocional mais apagada, o que também pode favorecer abandono silencioso do tratamento.

Adesão e intervalo: Como se trata de formulação de longa ação, a adesão irregular pode ficar menos visível do que com medicação oral, mas ainda aparece na sessão por faltas a aplicações, adiamentos, recusa parcial do tratamento ou uso errático de remédios concomitantes. Às vezes o paciente relata que “fica pior” em determinado ponto do mês, e isso pode corresponder tanto a expectativa subjetiva quanto a oscilação clínica real. Observar a cronologia entre aplicação, mudança no funcionamento e comparecimento às sessões ajuda a não confundir descontinuidade de cuidado com recaída espontânea.

Sinais físicos visíveis: Tremor fino, salivação aumentada, marcha mais travada, postura enrijecida ou dificuldade para iniciar movimentos podem aparecer de forma discreta e serem percebidos antes de virarem queixa espontânea. Esses sinais podem interferir na autoestima, na disposição para sair de casa e na qualidade do encontro terapêutico, inclusive pela vergonha de estar sendo observado. Quando surgem de modo novo ou se intensificam, vale registrar concretamente o que foi visto, porque o paciente nem sempre leva esse tipo de mudança para a consulta médica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Enantato de flufenazina é um antipsicótico de depósito, geralmente encontrado em quadros psicóticos crônicos ou quando há histórico de adesão irregular ao tratamento oral. No consultório, o ponto central não costuma ser “se tomou ou não tomou hoje”, mas como o paciente chega ao longo das semanas entre aplicações: mais organizado ou mais desconfiado, mais lentificado, rígido ou inquieto. Mudanças podem aparecer nos primeiros dias após a aplicação e também perto do fim do intervalo, quando alguns pacientes descrevem piora subjetiva ou retorno de sintomas. Vale acompanhar o padrão temporal da sessão, porque efeitos do medicamento, reemergência do quadro de base e uso irregular de outras medicações podem se confundir.

Perguntas úteis

- "Quando essa inquietação aparece, ela vem junto de pensamentos de medo ou preocupação, ou é mais uma sensação física de não conseguir ficar parado? , Você percebe que fica mais travado, lento ou com o corpo pesado mesmo quando o humor não está particularmente pior? , Nas semanas entre as aplicações, existe um período em que você costuma se sentir mais organizado ou mais confuso, ou isso não segue um padrão claro? , Esse jeito mais apagado tem sido vivido como alívio do sofrimento ou como perda de interesse, iniciativa e acesso ao que você sente? , Quando você falta, adia ou pensa em evitar a aplicação, isso costuma acontecer por esquecimento, incômodo com efeitos no corpo, desconfiança do tratamento ou outra razão mais específica? , Essas mudanças que você notou começaram depois de algum marco do tratamento ou combinam mais com algo que já acontecia antes, em fases do próprio quadro?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a mostrar rigidez
- tremor
- lentificação ou marcha visivelmente alterada
- pode valer alinhar com o psiquiatra para avaliação de tolerabilidade e impacto funcional
- Quando surge inquietação corporal nova
- persistente e pouco explicada pelo conteúdo emocional da sessão
- pode valer comunicar o médico para diferenciar ansiedade do quadro de um efeito relacionado ao tratamento
- Quando o paciente relata que evita ou adia aplicações por incômodo corporal
- vergonha ou desconfiança
- pode valer contato com o psiquiatra porque isso aumenta risco de descontinuidade silenciosa
- Quando há reemergência de desorganização
- persecutoriedade ou isolamento perto do fim do intervalo entre aplicações
- pode valer alinhar com o médico para situar se há padrão temporal consistente
- Quando o paciente parece progressivamente mais embotado
- com empobrecimento importante da iniciativa e da participação na sessão

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicação para discutir se a mudança acompanha estabilização do quadro ou outro fator clínico relevante

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente apresenta febre referida ou aparente
- confusão importante
- rigidez corporal marcada e piora rápida do estado geral.: Acionar avaliação médica no mesmo dia; se houver comprometimento importante do estado geral
- considerar rede de apoio e serviço de urgência
- Aparecem ideias de morte ou autoagressão com intenção
- plano ou perda importante de controle
- especialmente junto de piora psicótica ou agitação.: Fazer manejo de risco imediatamente
- acionar rede de apoio e avaliação psiquiátrica urgente
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

O foco clínico é acompanhar o padrão entre aplicações: organização psíquica, sinais motores visíveis, inquietação corporal e risco de adesão silenciosamente frágil.

078 HALOPERIDOL

Substância: Haloperidol.

Nomes Comerciais: Haloperidol, Halo, Hyporidrol, Uni Haloper, Furp-Haloperidol, Haldol

Uso comum

- Haloperidol é um antipsicótico típico que costuma aparecer no consultório em quadros psicóticos, agitação importante, mania e, em alguns contextos, como adjuvante para contenção de desorganização comportamental. Nas primeiras horas a dias, o terapeuta pode notar redução de agitação, mas também rigidez subjetiva, lentificação ou inquietação corporal difícil de nomear; ao longo de 1 a 3 semanas, vale acompanhar se a organização psíquica melhora sem custo excessivo em iniciativa, expressão afetiva e vínculo. O ponto central na sessão é diferenciar contenção útil de empobrecimento global, além de reconhecer sinais motores e adesão irregular que podem ser confundidos com piora do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Lentificação:** Alguns pacientes chegam mais contidos, com fala mais curta, menor espontaneidade e redução da expressividade. Isso pode acompanhar melhora de agitação ou desorganização, mas também pode ser vivido como travamento, perda de iniciativa ou afastamento do contato afetivo. Na leitura clínica, convém diferenciar se houve ganho de organização com preservação de acesso subjetivo ou se a sessão ficou empobrecida de modo novo, o que também pode ser confundido com sintomas negativos, depressão ou exaustão após crise recente.

Inquietação corporal: Pode surgir um desconforto motor em que a pessoa diz não conseguir ficar parada, muda de posição o tempo todo ou descreve tensão interna sem conseguir nomeá-la bem. Em sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, urgência para ir embora ou irritabilidade relacional, quando na verdade o componente corporal está em primeiro plano. A discriminação depende de observar se a inquietação é mais física do que cognitiva e se apareceu após início, retomada ou uso irregular, em vez de acompanhar diretamente temas emocionais trabalhados na sessão.

Rigidez e corpo: O paciente pode mencionar corpo duro, movimentos menos fluidos, rosto mais fixo, voz monótona ou dificuldade para relaxar. Esses sinais às vezes passam como retraimento defensivo, embotamento afetivo ou desinteresse, especialmente quando a pessoa fala pouco sobre o próprio desconforto. Vale observar se há mudança visível no gesto, na marcha, na mímica e no ritmo da fala, porque isso ajuda a não atribuir automaticamente ao funcionamento psíquico algo que pode estar sendo vivido **■■■■■■■** de tudo no corpo.

Cognição e contato: Em parte dos casos, a sessão fica mais concreta, com menor velocidade associativa e mais dificuldade para sustentar elaboração complexa. Isso pode refletir melhora de desorganização, mas também pode reduzir acesso narrativo e dar a impressão de baixa motivação ou resistência. A comparação com a linha de base e com o momento do tratamento é central, já que ressaca de internação, privação de sono, uso de outras medicações sedativas e flutuação do próprio quadro também alteram o contato clínico.

Adesão silenciosa: Com haloperidol, o abandono silencioso pode ocorrer quando o paciente se sente excessivamente travado, inquieto ou corporalmente desconfortável, mesmo sem verbalizar isso espontaneamente. Na sessão, aparecem faltas, oscilação brusca entre dias muito contidos e retorno de agitação, ou narrativas vagas de que 'não deu para continuar'. Isso pode ser lido como oposição, baixa aliança ou desorganização do quadro, quando às vezes o ponto decisivo é tolerabilidade ruim e uso irregular.

Virada do quadro: Quando o medicamento está sendo usado em contexto de psicose ou mania, a melhora parcial pode conviver com persistência de ideias delirantes, medo persecutório, impulsividade ou aceleração. O terapeuta pode encontrar um paciente aparentemente mais calmo, mas ainda pouco crítico, mais desconfiado ou com juízo prático comprometido. O risco aqui é supor estabilização apenas porque a agitação diminuiu; por isso, convém acompanhar separadamente comportamento observável, organização do pensamento e capacidade de autocuidado."

O que observar em sessão

- **Lentificação:** Alguns pacientes chegam mais contidos, com fala mais curta, menor espontaneidade e redução da expressividade. Isso pode acompanhar melhora de agitação ou desorganização, mas também pode ser vivido como travamento, perda de iniciativa ou afastamento do contato afetivo. Na leitura clínica, convém diferenciar se houve ganho de organização com preservação de acesso subjetivo ou se a sessão ficou empobrecida de modo novo, o que também pode ser confundido com sintomas negativos, depressão ou exaustão após crise recente.

Inquietação corporal: Pode surgir um desconforto motor em que a pessoa diz não conseguir ficar parada, muda de posição o tempo todo ou descreve tensão interna sem conseguir nomeá-la bem. Em sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, urgência para ir embora ou irritabilidade relacional, quando na verdade o componente corporal está em primeiro plano. A discriminação depende de observar se a inquietação é mais física do que cognitiva e se apareceu após início, retomada ou uso irregular, em vez de acompanhar diretamente temas emocionais trabalhados na sessão.

Rigidez e corpo: O paciente pode mencionar corpo duro, movimentos menos fluidos, rosto mais fixo, voz monótona ou dificuldade para relaxar. Esses sinais às vezes passam como retraimento defensivo, embotamento afetivo ou desinteresse, especialmente quando a pessoa fala pouco sobre o próprio desconforto. Vale observar se há mudança visível no gesto, na marcha, na mímica e no ritmo da fala, porque isso ajuda a não atribuir automaticamente ao funcionamento psíquico algo que pode estar sendo vivido **de tudo no corpo**.

Cognição e contato: Em parte dos casos, a sessão fica mais concreta, com menor velocidade associativa e mais dificuldade para sustentar elaboração complexa. Isso pode refletir melhora de desorganização, mas também pode reduzir acesso narrativo e dar a impressão de baixa motivação ou resistência. A comparação com a linha de base e com o momento do tratamento é central, já que ressaca de internação, privação de sono, uso de outras medicações sedativas e flutuação do próprio quadro também alteram o contato clínico.

Adesão silenciosa: Com haloperidol, o abandono silencioso pode ocorrer quando o paciente se sente excessivamente travado, inquieto ou corporalmente desconfortável, mesmo sem verbalizar isso espontaneamente. Na sessão, aparecem faltas, oscilação brusca entre dias muito contidos e retorno de agitação, ou narrativas vagas de que 'não deu para continuar'. Isso pode ser lido como oposição, baixa aliança ou desorganização do quadro, quando às vezes o ponto decisivo é tolerabilidade ruim e uso irregular.

Virada do quadro: Quando o medicamento está sendo usado em contexto de psicose ou mania, a melhora parcial pode conviver com persistência de ideias delirantes, medo persecutório, impulsividade ou aceleração. O terapeuta pode encontrar um paciente aparentemente mais calmo, mas ainda pouco crítico, mais desconfiado ou com juízo prático comprometido. O risco aqui é supor estabilização apenas porque a agitação diminuiu; por isso, convém acompanhar separadamente comportamento observável, organização do pensamento e capacidade de autocuidado.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Haloperidol é um antipsicótico típico que costuma aparecer no consultório em quadros psicóticos, agitação importante, mania e, em alguns contextos, como adjuvante para contenção de desorganização comportamental. Nas primeiras horas a dias, o terapeuta pode notar redução de agitação, mas também rigidez subjetiva, lentificação ou inquietação corporal difícil de nomear; ao longo de 1 a 3 semanas, vale acompanhar se a organização psíquica melhora sem custo excessivo em iniciativa, expressão afetiva e vínculo. O ponto central na sessão é diferenciar contenção útil de empobrecimento global, além de reconhecer sinais motores e adesão irregular que podem ser confundidos com piora do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está mais ansioso, isso vem mais como pensamentos acelerados e preocupação ou como uma necessidade física de se mexer e não conseguir ficar parado? , Desde que começou a se sentir mais contido, você percebe isso como alívio por estar menos agitado ou como se tivesse ficado travado e menos você mesmo? , Essa dificuldade para falar e pensar na sessão parece acompanhar cansaço e desânimo, ou surgiu junto com uma sensação corporal de peso, rigidez ou lentidão? , Nos dias em que você fica pior, isso acontece de modo mais contínuo ou aparece depois de períodos em que você deixou de tomar, tomou de forma irregular ou pensou em interromper? , Você se percebe mais calmo por dentro também, ou só mais parado por fora enquanto a cabeça continua acelerada, desconfiada ou pressionada? , Quando você evita sair, conversar ou fazer coisas, isso parece vir de medo e desconfiança, de falta de vontade, ou de desconforto corporal para se mover e estar com os outros?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve inquietação corporal intensa
- incapacidade de permanecer sentado ou piora importante da irritabilidade após início ou retomada do uso
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar agitação do quadro de um efeito que compromete adesão
- Quando a sessão mostra lentificação marcada
- rigidez visível
- fala muito empobrecida ou queda importante de iniciativa em relação à linha de base
- pode valer comunicar o médico assistente para contextualizar impacto funcional e tolerabilidade
- Quando há oscilação entre contenção excessiva e retorno de agitação
- especialmente com indícios de uso irregular ou interrupção por conta própria
- pode valer contato com o psiquiatra para alinhar leitura clínica e risco de descontinuidade
- Quando a agitação diminui
- mas persistem desorganização do pensamento
- desconfiança intensa
- impulsividade ou prejuízo de autocuidado

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicar o médico assistente para situar resposta parcial e risco clínico
- Quando o paciente evita relatar desconfortos corporais
- mas passa a faltar
- encurtar sessões ou insinuar abandono do tratamento medicamentoso
- pode valer alinhar com o psiquiatra porque esse padrão às vezes antecede interrupção silenciosa

Vermelho: tratar como urgência

- Febre ou mal-estar importante acompanhados de rigidez intensa
- confusão
- sudorese marcante ou rebaixamento importante do contato durante a sessão.: Tratar como urgência clínica
- acionar avaliação médica no mesmo dia e recorrer à emergência se não houver retaguarda rápida
- Retorno de ideias persecutórias ou grandiosas com forte agitação
- impulsividade
- perda de crítica e risco concreto para si ou para terceiros.: Fazer manejo de crise
- acionar psiquiatra e rede de apoio imediatamente e encaminhar para emergência quando houver risco atual
- Interrupção abrupta referida junto com piora rápida de agitação
- insônia importante
- desorganização ou reemergência de sintomas psicóticos.: Considerar situação de alto risco clínico
- contatar o psiquiatra no mesmo dia e avaliar necessidade de suporte emergencial conforme o grau de desorganização e risco

Frase clínica

Com haloperidol, o foco é distinguir contenção terapêutica de travamento global, reconhecendo sinais motores que facilmente se confundem com o quadro psíquico.

079 MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA

Substância: Maleato de Levomepromazina.

Nomes Comerciais: Maleato de Levomepromazina

Uso comum

- A levomepromazina é um antipsicótico sedativo que, no consultório, costuma aparecer mais pelo impacto sobre vigília, ritmo e disponibilidade psíquica do que por mudanças elaborativas finas. Pode ser usada em quadros psicóticos, agitação importante, insônia refratária ou como adjuvante em fases de grande desorganização. Nas primeiras semanas, vale acompanhar de perto sedação, lentificação, hipotensão percebida ao levantar e mudanças no padrão de participação na sessão; depois, o foco costuma migrar para adesão, embotamento e funcionalidade. Se houver interrupção irregular, a leitura clínica pode se confundir com retorno de insônia, ansiedade ou desorganização do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, longas pausas e dificuldade de sustentar o fio associativo podem aparecer já no início ou após mudanças recentes no uso, e às vezes dominam a sessão mais do que o sofrimento que motivou o tratamento. Na observação clínica, importa distinguir um paciente menos angustiado de um paciente menos acessível por rebaixamento de vigília. Eventos como privação de sono, uso de álcool, outras medicações sedativas ou piora depressiva também podem produzir apresentação semelhante.

Hipotensão e corpo: Alguns pacientes descrevem tontura ao levantar, sensação de fraqueza, visão escurecendo por instantes ou necessidade de sentar novamente, o que pode repercutir em medo de sair, quedas ou redução da rotina. Em sessão, isso pode aparecer como postura mais cautelosa, mudança lenta de posição e preocupação corporal que facilmente se confunde com ansiedade somática. Vale lembrar que desidratação, jejum, doença clínica intercorrente e outros psicotrópicos também podem participar desse quadro.

Embotamento e acesso afetivo: Com o passar das semanas, pode surgir uma redução da intensidade afetiva que o paciente vive como alívio, apatia ou sensação de estar amortecido. O terapeuta pode notar menor reatividade emocional, menos espontaneidade e elaboração mais pobre, mas isso não equivale automaticamente a melhora estável do quadro. Remissão parcial de sintomas, exaustão após crise, retraimento defensivo e sintomas negativos prévios podem confundir essa leitura.

Agitação paradoxal e inquietação: Embora a marca clínica mais lembrada seja a sedação, parte dos pacientes pode chegar mais inquieta, desconfortável no corpo ou incapaz de permanecer sentada com naturalidade. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, urgência interna ou irritabilidade sem elaboração, e o risco é atribuir tudo ao conteúdo emocional do encontro. A discriminação pede atenção ao vínculo temporal com o uso, à presença de desconforto motor novo e à diferença entre preocupação psíquica e mal-estar corporal pouco simbolizável.

Adesão e uso irregular: A adesão pode oscilar quando o paciente sente que o remédio derruba, atrapalha o trabalho, aumenta o sono ou produz sensação de estranhamento subjetivo. Em consultório, isso às vezes aparece indiretamente: faltas, inversão do ciclo sono-vigília, relato vago sobre horários, oscilação brusca entre sessões muito sedadas e outras mais aceleradas. Retorno de insônia, ansiedade, agitação ou desorganização após uso irregular pode ser lido como recaída pura se o terapeuta não explorar a continuidade real do tratamento.

Psicose e organização: Quando a levomepromazina entra em cena, muitas vezes o paciente já vinha com importante desorganização, agitação ou sofrimento intenso, o que torna a linha de base menos estável. Melhoras iniciais podem significar menor excitação comportamental sem recuperação equivalente de crítica, juízo ou capacidade de elaboração. Também o inverso ocorre: uma sessão mais silenciosa e contida pode sugerir estabilização quando há apenas maior sedação sobre um quadro ainda pouco organizado."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, longas pausas e dificuldade de sustentar o fio associativo podem aparecer já no início ou após mudanças recentes no uso, e às vezes dominam a sessão mais do que o sofrimento que motivou o tratamento. Na observação clínica, importa distinguir um paciente menos angustiado de um paciente menos acessível por rebaixamento de vigília. Eventos como privação de sono, uso de álcool, outras medicações sedativas ou piora depressiva também podem produzir apresentação semelhante.

Hipotensão e corpo: Alguns pacientes descrevem tontura ao levantar, sensação de fraqueza, visão escurecendo por instantes ou necessidade de sentar novamente, o que pode repercutir em medo de sair, quedas ou redução da rotina. Em sessão, isso pode aparecer como postura mais cautelosa, mudança lenta de posição e preocupação corporal que facilmente se confunde com ansiedade somática. Vale lembrar que desidratação, jejum, doença clínica intercorrente e outros psicotrópicos também podem participar desse quadro.

Embotamento e acesso afetivo: Com o passar das semanas, pode surgir uma redução da intensidade afetiva que o paciente vive como alívio, apatia ou sensação de estar "amortecido". O terapeuta pode notar menor reatividade emocional, menos espontaneidade e elaboração mais pobre, mas isso não equivale automaticamente a melhora estável do quadro. Remissão parcial de sintomas, exaustão após crise, retraimento defensivo e sintomas negativos prévios podem confundir essa leitura.

Agitação paradoxal e inquietação: Embora a marca clínica mais lembrada seja a sedação, parte dos pacientes pode chegar mais inquieta, desconfortável no corpo ou incapaz de permanecer sentada com naturalidade. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, urgência interna ou irritabilidade sem elaboração, e o risco é atribuir tudo ao conteúdo emocional do encontro. A discriminação pede atenção ao vínculo temporal com o uso, à presença de desconforto motor novo e à diferença entre preocupação psíquica e mal-estar corporal pouco simbolizável.

Adesão e uso irregular: A adesão pode oscilar quando o paciente sente que o remédio "derruba", atrapalha o trabalho, aumenta o sono ou produz sensação de estranhamento subjetivo. Em consultório, isso às vezes aparece indiretamente: faltas, inversão do ciclo sono-vigília, relato vago sobre horários, oscilação brusca entre sessões muito sedadas e outras mais aceleradas. Retorno de insônia, ansiedade, agitação ou desorganização após uso irregular pode ser lido como recaída pura se o terapeuta não explorar a continuidade real do tratamento.

Psicose e organização: Quando a levomepromazina entra em cena, muitas vezes o paciente já vinha com importante desorganização, agitação ou sofrimento intenso, o que torna a linha de base menos estável. Melhoras iniciais podem significar menor excitação comportamental sem recuperação equivalente de crítica, juízo ou capacidade de elaboração. Também o inverso ocorre: uma sessão mais silenciosa e contida pode sugerir estabilização quando há apenas maior sedação sobre um quadro ainda pouco organizado.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A levomepromazina é um antipsicótico sedativo que, no consultório, costuma aparecer mais pelo impacto sobre vigília, ritmo e disponibilidade psíquica do que por mudanças elaborativas finas. Pode ser usada em quadros psicóticos, agitação importante, insônia refratária ou como adjuvante em fases de grande desorganização. Nas primeiras semanas, vale acompanhar de perto sedação, lentificação, hipotensão percebida ao levantar e mudanças no padrão de participação na sessão; depois, o foco costuma migrar para adesão, embotamento e funcionalidade. Se houver interrupção irregular, a leitura clínica pode se confundir com retorno de insônia, ansiedade ou desorganização do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais apagado, isso vem como sono e peso no corpo ou como desânimo e falta de vontade de viver o dia? , Essa inquietação que apareceu parece mais uma preocupação com pensamentos e medos, ou um desconforto físico de não conseguir ficar parado mesmo sem um motivo claro? , Nos dias em que você dorme muito ou fica mais lento, você se percebe mais calmo por dentro ou apenas menos capaz de reagir e pensar com clareza? , Quando a sessão rende menos, você sente que está mais protegido da angústia ou mais distante de si e do que gostaria de dizer? , Essas oscilações entre dias mais sedados e dias mais agitados coincidem com mudanças no jeito como você tem conseguido tomar a medicação? , Quando a insônia ou a desorganização voltam, isso acontece de modo contínuo como antes do tratamento ou aparece mais depois de dias em que o uso saiu do padrão?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- relata uso irregular ou admite reduzir por conta própria porque se sente excessivamente sedado
- pode valer alinhar com o psiquiatra para prevenir abandono silencioso e leitura equivocada de recaída
- Quando a sessão mostra lentificação importante
- sonolência recorrente ou prejuízo funcional novo que interfere em trabalho
- autocuidado ou segurança ao sair sozinho
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisão clínica da tolerabilidade
- Quando surge inquietação corporal nova
- difícil de simbolizar
- especialmente se o paciente descreve incapacidade de permanecer parado
- pode valer comunicar o médico assistente para diferenciar ansiedade do quadro de um possível efeito do tratamento
- Quando persistem ideias delirantes
- grande desorganização ou agitação apesar de algumas semanas de uso e de aparente adesão
- pode valer contato com o psiquiatra para atualizar a leitura da resposta clínica

Amarelo: alinhar em breve

- Quando aparecem tonturas frequentes ao levantar
- quase quedas ou medo de cair que passa a restringir a rotina
- pode valer alinhar com o médico assistente pela repercussão funcional e risco físico

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente apresenta rebaixamento acentuado de consciência
- confusão importante
- fala muito desconexa ou dificuldade marcante de se manter responsivo na sessão.: Interromper o enquadre habitual
- avaliar necessidade de apoio imediato
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia; considerar emergência se não houver segurança clínica
- Há febre
- rigidez muscular evidente
- sudorese intensa e piora rápida do estado geral junto de confusão ou grande lentificação.: Tratar como situação médica urgente
- acionar atendimento de emergência e informar o médico assistente imediatamente
- Em contexto de psicose
- agitação ou rebaixamento importante
- o paciente expressa risco atual de se ferir
- ferir alguém ou não consegue garantir mínima autoproteção.: Adotar manejo de crise no mesmo dia
- mobilizar rede de apoio e acionar psiquiatra e emergência conforme necessidade

Frase clínica

O foco clínico costuma ser separar contenção útil de sedação excessiva, sem perder de vista adesão, funcionalidade e organização psíquica.

080 PERICIAZINA

Substância: Periciazina.

Nomes Comerciais: Neuleptil

Uso comum

- Periciazina é um antipsicótico sedativo da família das fenotiazinas, encontrado no consultório sobretudo em pacientes com agitação, irritabilidade importante, desorganização, insônia associada a quadros psiquiátricos ou uso como coadjuvante em fases mais turbulentas do tratamento. Nas primeiras semanas, o que costuma aparecer mais claramente na sessão é mudança no nível de alerta, lentificação, redução da reatividade e, às vezes, sensação subjetiva de “ficar apagado”. Quando há benefício, ele tende a ser percebido cedo como contenção da agitação; ao longo das semanas, vale acompanhar se isso se traduz em maior organização psíquica ou apenas em sedação. O ponto central na sessão é diferenciar apaziguamento clínico de embotamento, piora cognitiva, adesão irregular ou oscilação do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar o fio associativo podem aparecer logo no início ou após mudanças recentes no uso, e às vezes chegam à sessão como "calma" que o paciente descreve com ambivalência. Na observação clínica, importa notar se houve redução da angústia com preservação de contato e elaboração, ou se o paciente parece excessivamente amortecido, com acesso afetivo empobrecido. Esse quadro pode se confundir com exaustão, piora depressiva, privação de sono prévia, uso concomitante de outras medicações sedativas ou consumo de álcool.

Agitação e contenção: Em alguns casos, a sessão mostra menos impulsividade, menos explosividade e maior tolerância à frustração, o que pode representar melhora do quadro que motivou o uso. Ainda assim, convém observar se a redução da agitação veio acompanhada de maior capacidade reflexiva ou apenas de inibição comportamental. Eventos ambientais menos estressantes, contenção familiar mais intensa ou adesão irregular também podem produzir oscilações parecidas e confundir a leitura longitudinal.

Cognição e contato: Pode surgir queixa de cabeça "pesada", dificuldade de concentração, lentificação para responder e menor nitidez no pensamento, especialmente quando o paciente já chega vulnerável por sofrimento intenso ou sono ruim. Na sessão, isso pode reduzir a capacidade de simbolização e fazer parecer que houve retraimento defensivo ou resistência, quando talvez haja interferência do tratamento ou do estado geral. Também vale considerar progressão do quadro psiquiátrico, uso de outras substâncias e baixa adesão, sobretudo quando o padrão varia muito entre encontros.

Inquietação paradoxal: Embora o mais esperado seja contenção, parte dos pacientes pode comparecer mais inquieta, desconfortável no corpo, levantando-se, mudando de posição ou descrevendo tensão interna difícil de nomear. Na clínica, isso pode ser confundido com ansiedade habitual, crise situacional, irritabilidade do próprio quadro ou dificuldade de permanecer na sessão por razões transferenciais. O dado discriminativo costuma estar na qualidade corporal e na temporalidade: uma inquietação nova, persistente e pouco ligada ao conteúdo da sessão merece registro cuidadoso.

Adesão e uso irregular: Como a experiência subjetiva pode oscilar entre alívio e sensação de apagamento, não é incomum que o paciente altere o uso por conta própria, omita tomadas ou compareça sem clareza sobre a regularidade. Na sessão, isso aparece como variação brusca de alerta, humor, irritabilidade ou sono entre encontros, às vezes sem correspondência com eventos de vida. Quando o padrão clínico muda de forma serrilhada, vale explorar a sequência concreta dos dias para não atribuir automaticamente tudo à evolução do quadro.

Sinais físicos visíveis: Boca seca, aspecto mais sonolento, postura mais rígida, fala pastosa, tremor fino ou desconforto motor podem aparecer de modo suficientemente visível para interferir no trabalho terapêutico. O ponto não é nomear o fenômeno, mas notar quando o corpo passa a ocupar o centro da sessão e reduz a disponibilidade psíquica. Ansiedade somatizada, outras medicações e condições clínicas intercorrentes também podem produzir apresentações semelhantes, por isso a observação descritiva costuma ser mais útil do que a interpretação apressada."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar o fio associativo podem aparecer logo no início ou após mudanças recentes no uso, e às vezes chegam à sessão como “calma” que o paciente descreve com ambivalência. Na observação clínica, importa notar se houve redução da angústia com preservação de contato e elaboração, ou se o paciente parece excessivamente amortecido, com acesso afetivo empobrecido. Esse quadro pode se confundir com exaustão, piora depressiva, privação de sono prévia, uso concomitante de outras medicações sedativas ou consumo de álcool.

Agitação e contenção: Em alguns casos, a sessão mostra menos impulsividade, menos explosividade e maior tolerância à frustração, o que pode representar melhora do quadro que motivou o uso. Ainda assim, convém observar se a redução da agitação veio acompanhada de maior capacidade reflexiva ou apenas de inibição comportamental. Eventos ambientais menos estressantes, contenção familiar mais intensa ou adesão irregular também podem produzir oscilações parecidas e confundir a leitura longitudinal.

Cognição e contato: Pode surgir queixa de cabeça “pesada”, dificuldade de concentração, lentificação para responder e menor nitidez no pensamento, especialmente quando o paciente já chega vulnerável por sofrimento intenso ou sono ruim. Na sessão, isso pode reduzir a capacidade de simbolização e fazer parecer que houve retraimento defensivo ou resistência, quando talvez haja interferência do tratamento ou do estado geral. Também vale considerar progressão do quadro psiquiátrico, uso de outras substâncias e baixa adesão, sobretudo quando o padrão varia muito entre encontros.

Inquietação paradoxal: Embora o mais esperado seja contenção, parte dos pacientes pode comparecer mais inquieta, desconfortável no corpo, levantando-se, mudando de posição ou descrevendo tensão interna difícil de nomear. Na clínica, isso pode ser confundido com ansiedade habitual, crise situacional, irritabilidade do próprio quadro ou dificuldade de permanecer na sessão por razões transferenciais. O dado discriminativo costuma estar na qualidade corporal e na temporalidade: uma inquietação nova, persistente e pouco ligada ao conteúdo da sessão merece registro cuidadoso.

Adesão e uso irregular: Como a experiência subjetiva pode oscilar entre alívio e sensação de apagamento, não é incomum que o paciente altere o uso por conta própria, omita tomadas ou compareça sem clareza sobre a regularidade. Na sessão, isso aparece como variação brusca de alerta, humor, irritabilidade ou sono entre encontros, às vezes sem correspondência com eventos de vida. Quando o padrão clínico muda de forma serrilhada, vale explorar a sequência concreta dos dias para não atribuir automaticamente tudo à evolução do quadro.

Sinais físicos visíveis: Boca seca, aspecto mais sonolento, postura mais rígida, fala pastosa, tremor fino ou desconforto motor podem aparecer de modo suficientemente visível para interferir no trabalho terapêutico. O ponto não é nomear o fenômeno, mas notar quando o corpo passa a ocupar o centro da sessão e reduz a disponibilidade psíquica. Ansiedade somatizada, outras medicações e condições clínicas intercorrentes também podem produzir apresentações semelhantes, por isso a observação descritiva costuma ser mais útil do que a interpretação apressada.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Periciazina é um antipsicótico sedativo da família das fenotiazinas, encontrado no consultório sobretudo em pacientes com agitação, irritabilidade importante, desorganização, insônia associada a quadros psiquiátricos ou uso como coadjuvante em fases mais turbulentas do tratamento. Nas primeiras semanas, o que costuma aparecer mais claramente na sessão é mudança no nível de alerta, lentificação, redução da reatividade e, às vezes, sensação subjetiva de “ficar apagado”. Quando há benefício, ele tende a ser percebido cedo como contenção da agitação; ao longo das semanas, vale acompanhar se isso se traduz em maior organização psíquica ou apenas em sedação. O ponto central na sessão é diferenciar apaziguamento clínico de embotamento, piora cognitiva, adesão irregular ou oscilação do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está mais calmo, isso vem junto com mais clareza para pensar e escolher ou com sensação de estar meio apagado por dentro? , Essa dificuldade de se concentrar apareceu como continuação do seu estado anterior ou começou depois de uma mudança recente na rotina de uso da medicação? , Quando essa inquietação aparece, ela parece ligada a pensamentos e preocupações específicas ou é mais um desconforto no corpo, difícil de explicar mesmo quando a cabeça está relativamente quieta? , Nos dias em que você fica mais sonolento ou mais irritado, isso segue algum padrão de horário ou de regularidade no uso, ou parece independente disso? , Essa redução da impulsividade tem vindo com mais capacidade de conversar e elaborar o que sente, ou você percebe mais como um freio que te deixa menos vivo? , Entre uma sessão e outra, houve dias em que você deixou de tomar, tomou de modo diferente do habitual ou evitou usar porque não gostou de como ficou?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando a sessão mostra sedação importante
- lentificação ou prejuízo de contato que passam a comprometer o trabalho terapêutico e a funcionalidade cotidiana
- pode valer alinhar com o psiquiatra para contextualizar o impacto clínico observado
- Quando surge inquietação corporal nova
- persistente e pouco explicada pelo conteúdo emocional da sessão
- pode valer comunicar o médico assistente para ajudar na diferenciação entre ansiedade do quadro e efeito do tratamento
- Quando o paciente relata uso irregular
- interrupções frequentes ou abandono silencioso por se sentir excessivamente apagado
- pode valer contato com o psiquiatra porque a adesão fica fragilizada e a leitura da evolução clínica se torna menos confiável
- Quando aparecem tremor
- rigidez
- fala mais travada ou outras mudanças corporais visíveis que não estavam presentes na linha de base

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico para registrar a mudança e seu impacto no funcionamento
- Quando
- após algumas semanas
- há pouca melhora da agitação ou da desorganização apesar de uso aparentemente regular
- pode valer comunicar o psiquiatra para compartilhar a impressão longitudinal do consultório

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- aparecem febre ou mal-estar importante junto de rigidez acentuada
- confusão marcante ou rebaixamento importante do estado de alerta.: Tratar como urgência clínica
- acionar avaliação médica no mesmo dia e recorrer à rede de apoio e emergência se necessário
- O paciente apresenta rebaixamento importante da consciência
- fala muito arrastada
- dificuldade de se manter desperto ou piora súbita do estado geral durante a sessão.: Interromper o trabalho habitual
- buscar avaliação médica imediata e acionar acompanhante
- rede de apoio ou emergência conforme o contexto

Frase clínica

O foco clínico é distinguir contenção da agitação de sedação excessiva, lentificação e adesão irregular que embaralham a leitura da sessão.

081 SULPIRIDA

Substância: Sulpirida.

Nomes Comerciais: Equilid

Uso comum

- A sulpirida é um antipsicótico que pode aparecer no consultório em uso para quadros psicóticos, sintomas somáticos com forte componente ansioso e, em alguns contextos, humor ou ansiedade. Nas primeiras 1 a 3 semanas, costuma valer atenção redobrada para sedação, inquietação corporal, lentificação ou piora subjetiva da disposição; ao longo de algumas semanas, o terapeuta acompanha se há redução de desorganização, agitação ou sofrimento persecutório sem perda excessiva de acesso afetivo. O ponto central na sessão é diferenciar melhora clínica de embotamento, além de notar sinais motores e adesão irregular, que podem confundir a leitura do quadro.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com fala menos espontânea, maior latência de resposta, sonolência ou dificuldade de sustentar elaboração. Isso pode se confundir tanto com melhora de agitação e ansiedade quanto com piora depressiva, privação de sono ou uso concomitante de outras medicações sedativas. Vale comparar com a linha de base: o paciente está mais organizado e presente, ainda que mais lento, ou parece apagado, com queda global de vitalidade e engajamento?

Inquietação corporal: Alguns pacientes descrevem um desconforto difícil de nomear, com necessidade de se mexer, trocar de posição ou sensação de não conseguir ficar em repouso. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, tensão por tema sensível ou reatividade transferencial, mas ganha outro peso quando surge de modo novo, corporalmente marcado e pouco ligado ao conteúdo da fala. A discriminação clínica depende de observar se a inquietação acompanha pensamentos ansiosos reconhecíveis ou se aparece como mal-estar motor relativamente autônomo.

Acesso afetivo: Quando há redução de intensidade emocional, o terapeuta pode notar menos reatividade, menos urgência e menor carga persecutória, o que às vezes representa ganho clínico real. Em outros casos, surge um achatamento subjetivo: o paciente diz que sofre menos, mas também sente menos, pensa menos e se reconhece menos na própria vida psíquica. Eventos de vida, exaustão e retraimento defensivo também podem produzir esse aspecto, por isso ajuda observar se houve melhora de organização interna junto com preservação mínima de interesse, vínculo e capacidade de simbolização.

Cognição e organização: Pode haver melhora da desorganização, da tangencialidade ou da pressão interna, tornando a sessão mais acompanhável e o pensamento mais linear. Por outro lado, lentificação cognitiva, dificuldade de concentração e empobrecimento associativo podem aparecer e ser lidos apressadamente como déficit do quadro de base. A comparação entre clareza, iniciativa e flexibilidade mental ao longo das semanas ajuda a distinguir contenção útil de um custo cognitivo que começa a comprometer o trabalho terapêutico.

Adesão e continuidade: A adesão irregular pode aparecer de forma indireta: oscilação brusca entre sessões, retorno de estranheza, piora de sono, mais desconfiança ou relato vago de que 'alguns dias não deu'. Como a sulpirida pode ser abandonada silenciosamente quando o paciente se sente excessivamente lento, desconfortável ou pouco parecido consigo mesmo, a leitura do processo pode se confundir com recaída espontânea ou resistência ao tratamento. Vale observar mudanças abruptas no padrão da sessão e explorar a continuidade do uso sem assumir causalidade única.

Sinais hormonais e sexualidade: Em alguns casos, surgem mudanças que o paciente traz mais como impacto subjetivo do que como queixa médica: queda de libido, desconforto com o corpo, alterações menstruais ou secreção mamária, com vergonha ou evitação do tema. Isso pode repercutir em autoestima, vínculo amoroso e sensação de estranhamento corporal, sendo facilmente confundido com depressão, conflito relacional ou retraimento defensivo. Quando aparece, o mais útil na sessão é nomear o impacto psíquico e registrar a temporalidade, porque esse tipo de efeito pode favorecer abandono silencioso."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com fala menos espontânea, maior latência de resposta, sonolência ou dificuldade de sustentar elaboração. Isso pode se confundir tanto com melhora de agitação e ansiedade quanto com piora depressiva, privação de sono ou uso concomitante de outras medicações sedativas. Vale comparar com a linha de base: o paciente está mais organizado e presente, ainda que mais lento, ou parece apagado, com queda global de vitalidade e engajamento?

Inquietação corporal: Alguns pacientes descrevem um desconforto difícil de nomear, com necessidade de se mexer, trocar de posição ou sensação de não conseguir ficar em repouso. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, tensão por tema sensível ou reatividade transferencial, mas ganha outro peso quando surge de modo novo, corporalmente marcado e pouco ligado ao conteúdo da fala. A discriminação clínica depende de observar se a inquietação acompanha pensamentos ansiosos reconhecíveis ou se aparece como mal-estar motor relativamente autônomo.

Acesso afetivo: Quando há redução de intensidade emocional, o terapeuta pode notar menos reatividade, menos urgência e menor carga persecutória, o que às vezes representa ganho clínico real. Em outros casos, surge um achatamento subjetivo: o paciente diz que sofre menos, mas também sente menos, pensa menos e se reconhece menos na própria vida psíquica. Eventos de vida, exaustão e retraimento defensivo também podem produzir esse aspecto, por isso ajuda observar se houve melhora de organização interna junto com preservação mínima de interesse, vínculo e capacidade de simbolização.

Cognição e organização: Pode haver melhora da desorganização, da tangencialidade ou da pressão interna, tornando a sessão mais acompanhável e o pensamento mais linear. Por outro lado, lentificação cognitiva, dificuldade de concentração e empobrecimento associativo podem aparecer e ser lidos apressadamente como déficit do quadro de base. A comparação entre clareza, iniciativa e flexibilidade mental ao longo das semanas ajuda a distinguir contenção útil de um custo cognitivo que começa a comprometer o trabalho terapêutico.

Adesão e continuidade: A adesão irregular pode aparecer de forma indireta: oscilação brusca entre sessões, retorno de estranheza, piora de sono, mais desconfiança ou relato vago de que 'alguns dias não deu'. Como a sulpirida pode ser abandonada silenciosamente quando o paciente se sente excessivamente lento, desconfortável ou pouco parecido consigo mesmo, a leitura do processo pode se confundir com recaída espontânea ou resistência ao tratamento. Vale observar mudanças abruptas no padrão da sessão e explorar a continuidade do uso sem assumir causalidade única.

Sinais hormonais e sexualidade: Em alguns casos, surgem mudanças que o paciente traz mais como impacto subjetivo do que como queixa médica: queda de libido, desconforto com o corpo, alterações menstruais ou secreção mamária, com vergonha ou evitação do tema. Isso pode repercutir em autoestima, vínculo amoroso e sensação de estranhamento corporal, sendo facilmente confundido com depressão, conflito relacional ou retraimento defensivo. Quando aparece, o mais útil na sessão é nomear o impacto psíquico e registrar a temporalidade, porque esse tipo de efeito pode favorecer abandono silencioso.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A sulpirida é um antipsicótico que pode aparecer no consultório em uso para quadros psicóticos, sintomas somáticos com forte componente ansioso e, em alguns contextos, humor ou ansiedade. Nas primeiras 1 a 3 semanas, costuma valer atenção redobrada para sedação, inquietação corporal, lentificação ou piora subjetiva da disposição; ao longo de algumas semanas, o terapeuta acompanha se há redução de desorganização, agitação ou sofrimento persecutório sem perda excessiva de acesso afetivo. O ponto central na sessão é diferenciar melhora clínica de embotamento, além de notar sinais motores e adesão irregular, que podem confundir a leitura do quadro.

Perguntas úteis

- "Quando essa lentidão aparece, você se sente mais organizado e tranquilo ou mais apagado e distante de si? , Essa inquietação vem junto de pensamentos ansiosos e preocupações reconhecíveis, ou é mais uma sensação física de não conseguir ficar parado mesmo sem um motivo claro? , Você sente que está sofrendo menos porque as ideias ficaram mais manejáveis, ou porque ficou com menos acesso ao que sente no geral? , Nos dias em que você parece muito diferente de uma sessão para outra, houve alguma mudança na regularidade com que tem tomado a medicação? , Essa queda no interesse sexual ou esse estranhamento com o corpo apareceu junto de mudanças na relação ou no humor, ou surgiu mais como algo novo no seu funcionamento corporal? , Quando o pensamento fica mais lento, você percebe também menos confusão e mais clareza, ou sente que perdeu agilidade sem ganhar organização?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar persistentemente muito sonolento
- lentificado ou com queda importante de participação na sessão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para avaliar impacto funcional e tolerabilidade
- Quando surge inquietação corporal nova
- repetida e pouco explicável pelo conteúdo emocional da sessão
- pode valer comunicar ao médico assistente para diferenciar ansiedade do quadro de um possível efeito motor
- Quando aparecem sinais de abandono silencioso
- uso irregular ou interrupções frequentes com oscilação clínica entre sessões
- pode valer alinhar com o psiquiatra para reduzir ruído na leitura do caso
- Quando o paciente relata queda importante de libido
- alterações menstruais
- secreção mamária ou intenso estranhamento corporal
- pode valer comunicar ao médico assistente porque esses fatores costumam pesar na adesão
- Quando
- após algumas semanas
- não se observa redução de desorganização

Amarelo: alinhar em breve

- agitação ou sofrimento persecutório
- ou há piora progressiva do funcionamento
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisão do momento clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecimento de febre
- rigidez importante
- confusão marcante ou rebaixamento acentuado do estado geral durante o período de uso.: Tratar como urgência clínica
- acionar avaliação médica no mesmo dia e recorrer à rede de apoio e emergência se necessário
- Retorno rápido de intensa desorganização
- medo persecutório
- agitação grave ou comportamento muito fora do padrão com perda de crítica.: Fazer manejo de crise
- acionar o psiquiatra no mesmo dia e mobilizar rede de apoio e emergência conforme o risco

Frase clínica

O foco é distinguir contenção útil de embotamento, além de notar inquietação motora e sinais de adesão irregular que alteram o padrão da sessão.

082 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA

Substância: Cloridrato de Difenidramina.

Nomes Comerciais: Lenix, Difenidrin

Uso comum

- Cloridrato de difenidramina é um anti-histamínico sedativo que pode aparecer no consultório quando o paciente o usa para alergias, sintomas gripais ou, por conta própria, para dormir. No contexto da terapia, o mais relevante costuma ser o efeito nas primeiras horas após o uso e no dia seguinte: sonolência, lentificação, atenção mais frouxa e, em alguns casos, irritabilidade ou sensação de “ressaca”. Como o uso pode ser intermitente, vale acompanhar a relação temporal entre tomada, qualidade do sono, funcionamento matinal e variações do padrão da sessão, para não confundir efeito agudo da medicação com piora depressiva, exaustão por estresse ou privação de sono.

O paciente pode relatar

- **"Sedação diurna:** Em sessão, o paciente pode chegar mais sonolento, com fala lenta, menor iniciativa associativa e dificuldade de sustentar o fio da conversa, sobretudo quando houve uso na noite anterior ou poucas horas antes. Isso pode se parecer com rebaixamento depressivo, esgotamento por rotina ou efeito de outras substâncias sedativas. A pista clínica costuma estar na oscilação entre sessões e na discrepância entre cansaço subjetivo e linha de base habitual de humor e interesse.

Sono e ressaca: Alguns pacientes descrevem que “apagaram” mais facilmente, mas acordaram pesados, confusos ou pouco restaurados. Na sessão, isso pode aparecer como baixa tolerância à frustração, menor acesso reflexivo e sensação de estar funcionando em marcha reduzida. Convém diferenciar se houve melhora real do sono, se o descanso foi apenas mais longo porém pouco reparador, ou se a noite ruim decorreu de ansiedade, dor, alergia ou hábitos de sono irregulares.

Cognição e atenção: Pode haver lapsos de atenção, memória imediata mais frágil e dificuldade para acompanhar raciocínios mais complexos, especialmente em uso próximo ao horário da sessão. Esse quadro pode ser confundido com ansiedade elevada, TDAH, sobrecarga emocional ou privação de sono. Quando a oscilação cognitiva acompanha dias de uso e melhora fora deles, a hipótese de efeito medicamentoso ganha peso observacional, sem excluir fatores concorrentes.

Uso intermitente: Como a difenidramina muitas vezes é usada “quando precisa”, o padrão clínico pode ficar irregular e difícil de ler. O terapeuta pode notar sessões muito diferentes entre si, sem mudança proporcional nos eventos de vida ou no quadro de base. Vale observar se o paciente usa em noites específicas, em períodos de alergia ou como estratégia para insônia, porque a adesão não contínua pode produzir variações que parecem instabilidade emocional, mas seguem um ritmo mais situacional.

Paradoxo e agitação: Em parte dos pacientes, em vez de acalmar, o uso pode vir acompanhado de inquietação, irritabilidade ou sensação subjetiva de estar “estranho”, sobretudo quando o paciente esperava relaxar. Na sessão, isso pode ser confundido com ansiedade basal, reação a conflitos recentes ou ativação por outras substâncias, como cafeína. O ponto discriminativo é a mudança relativamente abrupta após o uso e a presença de desconforto corporal ou mental pouco típico do padrão habitual do paciente."

O que observar em sessão

- **Sedação diurna:** Em sessão, o paciente pode chegar mais sonolento, com fala lenta, menor iniciativa associativa e dificuldade de sustentar o fio da conversa, sobretudo quando houve uso na noite anterior ou poucas horas antes. Isso pode se parecer com rebaixamento depressivo, esgotamento por rotina ou efeito de outras substâncias sedativas. A pista clínica costuma estar na oscilação entre sessões e na discrepância entre cansaço subjetivo e linha de base habitual de humor e interesse.

Sono e ressaca: Alguns pacientes descrevem que “apagaram” mais facilmente, mas acordaram pesados, confusos ou pouco restaurados. Na sessão, isso pode aparecer como baixa tolerância à frustração, menor acesso reflexivo e sensação de estar funcionando em marcha reduzida. Convém diferenciar se houve melhora real do sono, se o descanso foi apenas mais longo porém pouco reparador, ou se a noite ruim decorreu de ansiedade, dor, alergia ou hábitos de sono irregulares.

Cognição e atenção: Pode haver lapsos de atenção, memória imediata mais frágil e dificuldade para acompanhar raciocínios mais complexos, especialmente em uso próximo ao horário da sessão. Esse quadro pode ser confundido com ansiedade elevada, TDAH, sobrecarga emocional ou privação de sono. Quando a oscilação cognitiva acompanha dias de uso e melhora fora deles, a hipótese de efeito medicamentoso ganha peso observacional, sem excluir fatores concorrentes.

Uso intermitente: Como a difenidramina muitas vezes é usada “quando precisa”, o padrão clínico pode ficar irregular e difícil de ler. O terapeuta pode notar sessões muito diferentes entre si, sem mudança proporcional nos eventos de vida ou no quadro de base. Vale observar se o paciente usa em noites específicas, em períodos de alergia ou como estratégia para insônia, porque a adesão não contínua pode produzir variações que parecem instabilidade emocional, mas seguem um ritmo mais situacional.

Paradoxo e agitação: Em parte dos pacientes, em vez de acalmar, o uso pode vir acompanhado de inquietação, irritabilidade ou sensação subjetiva de estar “estranho”, sobretudo quando o paciente esperava relaxar. Na sessão, isso pode ser confundido com ansiedade basal, reação a conflitos recentes ou ativação por outras substâncias, como cafeína. O ponto discriminativo é a mudança relativamente abrupta após o uso e a presença de desconforto corporal ou mental pouco típico do padrão habitual do paciente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Cloridrato de difenidramina é um anti-histamínico sedativo que pode aparecer no consultório quando o paciente o usa para alergias, sintomas gripais ou, por conta própria, para dormir. No contexto da terapia, o mais relevante costuma ser o efeito nas primeiras horas após o uso e no dia seguinte: sonolência, lentificação, atenção mais frouxa e, em alguns casos, irritabilidade ou sensação de “ressaca”. Como o uso pode ser intermitente, vale acompanhar a relação temporal entre tomada, qualidade do sono, funcionamento matinal e variações do padrão da sessão, para não confundir efeito agudo da medicação com piora depressiva, exaustão por estresse ou privação de sono.

Perguntas úteis

- "Quando você fica mais lento ou sonolento, isso aparece de modo parecido em todos os dias ou costuma acontecer depois de noites em que tomou esse remédio? , No dia seguinte ao uso, você sente que dormiu melhor de fato ou que apenas ficou mais apagado, mas acordou pesado e pouco descansado? , Essa dificuldade de atenção que aparece aqui na sessão também acontece em dias sem usar nada para alergia ou para dormir? , Quando você fica mais irritado ou inquieto, isso vem junto de pensamentos acelerados e ansiedade habitual, ou parece um mal-estar mais corporal e diferente do seu padrão? , Essas variações entre uma sessão e outra combinam mais com o que aconteceu na sua semana ou com dias específicos em que você tomou o medicamento?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a usar a medicação com frequência para conseguir dormir
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o lugar desse uso no quadro geral de sono e funcionamento diurno
- Quando a sonolência
- a lentificação ou a confusão começam a interferir de forma consistente no trabalho
- nos estudos ou na própria psicoterapia
- pode valer comunicar o médico para revisão clínica da tolerabilidade
- Quando surgem irritabilidade ou inquietação claramente temporizadas ao uso e pouco compatíveis com o padrão habitual do paciente
- pode valer alinhar com o médico para discriminar efeito da medicação de evolução do quadro
- Quando o paciente alterna uso e interrupção de forma pouco rastreável e isso embaralha a leitura clínica da semana
- pode valer comunicar o médico para contextualizar adesão irregular e impacto funcional

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- o paciente apresenta sonolência intensa
- fala muito arrastada
- desorientação ou dificuldade importante para se manter acordado e responsivo.: Interromper a exploração psicoterápica
- avaliar segurança imediata
- acionar apoio para não permanecer sozinho se necessário e buscar contato médico no mesmo dia
- Após uso recente
- aparecem agitação intensa
- confusão marcante ou mudança abrupta do estado mental que foge claramente da linha de base do paciente.: Tratar como alteração aguda do estado clínico

Vermelho: tratar como urgência

- acionar o médico no mesmo dia e considerar rede de apoio ou avaliação de urgência conforme a gravidade

Frase clínica

O foco clínico costuma ser separar sedação e lentificação transitórias de piora do quadro de base ou de sono não reparador.

083 CLORIDRATO DE FLURAZEPAM

Substância: Cloridrato de Flurazepam.

Nomes Comerciais: Dalmadorm

Uso comum

- Cloridrato de flurazepam é um benzodiazepínico hipnótico, encontrado em pacientes com queixa de insônia, sobretudo quando o sono passou a organizar a narrativa clínica e a rotina. Na sessão, o ponto central costuma ser distinguir melhora do sono de sedação residual, lentificação e uso que vai se tornando necessário para dormir. Efeitos percebidos podem aparecer já nas primeiras noites; nas primeiras 1 a 2 semanas vale observar se há sonolência diurna, piora de atenção e mudanças no padrão da sessão. Após uso contínuo por semanas, ganham peso sinais de tolerância subjetiva, adesão irregular e desconforto quando a tomada falha, o que pode se confundir com recrudescimento da ansiedade ou da própria insônia.

O paciente pode relatar

- **"Sedação diurna:** Alguns pacientes chegam mais lentificados, com fala mais arrastada, menor vivacidade associativa ou dificuldade de sustentar atenção, especialmente em sessões pela manhã. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, exaustão por insônia crônica ou desinvestimento no processo, quando às vezes acompanha o início do uso ou noites em que o efeito parece se estender para o dia seguinte. Vale comparar com a linha de base da sessão, com o horário em que o paciente costuma tomar a medicação e com a qualidade do sono relatada nos dias anteriores.

Sono e rebote: Pode haver alívio inicial da dificuldade para adormecer, mas o relato nem sempre vem acompanhado de sensação de descanso real ou de melhora funcional durante o dia. Quando o paciente descreve noites muito piores ao esquecer, atrasar ou evitar a tomada, a leitura pode oscilar entre insônia de rebote, ansiedade antecipatória e retorno do padrão prévio de sono. Na sessão, ajuda observar se a piora aparece de modo abrupto em noites específicas ou se acompanha estressores, ruminação e mudanças na rotina.

Cognição e memória: Esquecimentos, sensação de cabeça enevoada e dificuldade de recuperar detalhes recentes podem aparecer no consultório como perda do fio, menor capacidade de elaboração ou empobrecimento do material associativo. Esse quadro pode ser confundido com ansiedade elevada, privação de sono, uso de álcool ou outras medicações sedativas, além de sobrecarga emocional. O dado mais útil costuma ser a mudança em relação ao funcionamento habitual do paciente e sua distribuição ao longo do dia.

Uso psicológico: Em parte dos casos, o medicamento passa a ocupar um lugar central na sensação de segurança para dormir, e a sessão começa a girar em torno do medo de não conseguir descansar sem ele. Isso não equivale por si só a dependência, mas pode sinalizar estreitamento de repertório de enfrentamento e aumento da apreensão noturna. Também aqui é fácil confundir efeito do contexto de vida, agravamento ansioso e um padrão de monitoramento corporal que antecede o sono.

Adesão e mistura: Uso irregular, tomada em horários variáveis ou combinação com álcool e outros sedativos podem alterar bastante o que aparece na sessão: de sonolência marcada a noites ruins seguidas de maior irritabilidade. O paciente nem sempre espontaneamente inclui esses detalhes, sobretudo quando sente vergonha, minimiza o impacto ou entende a medicação como algo já estabilizado. Quando o padrão oscila muito de uma semana para outra, vale considerar menos uma mudança do quadro de base e mais uma variação no modo de uso."

O que observar em sessão

- **Sedação diurna:** Alguns pacientes chegam mais lentificados, com fala mais arrastada, menor vivacidade associativa ou dificuldade de sustentar atenção, especialmente em sessões pela manhã. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, exaustão por insônia crônica ou desinvestimento no processo, quando às vezes acompanha o início do uso ou noites em que o efeito parece se estender para o dia seguinte. Vale comparar com a linha de base da sessão, com o horário em que o paciente costuma tomar a medicação e com a qualidade do sono relatada nos dias anteriores.

Sono e rebote: Pode haver alívio inicial da dificuldade para adormecer, mas o relato nem sempre vem acompanhado de sensação de descanso real ou de melhora funcional durante o dia. Quando o paciente descreve noites muito piores ao esquecer, atrasar ou evitar a tomada, a leitura pode oscilar entre insônia de rebote, ansiedade antecipatória e retorno do padrão prévio de sono. Na sessão, ajuda observar se a piora aparece de modo abrupto em noites específicas ou se acompanha estressores, ruminação e mudanças na rotina.

Cognição e memória: Esquecimentos, sensação de cabeça enevoada e dificuldade de recuperar detalhes recentes podem aparecer no consultório como perda do fio, menor capacidade de elaboração ou empobrecimento do material associativo. Esse quadro pode ser confundido com ansiedade elevada, privação de sono, uso de álcool ou outras medicações sedativas, além de sobrecarga emocional. O dado mais útil costuma ser a mudança em relação ao funcionamento habitual do paciente e sua distribuição ao longo do dia.

Uso psicológico: Em parte dos casos, o medicamento passa a ocupar um lugar central na sensação de segurança para dormir, e a sessão começa a girar em torno do medo de não conseguir descansar sem ele. Isso não equivale por si só a dependência, mas pode sinalizar estreitamento de repertório de enfrentamento e aumento da apreensão noturna. Também aqui é fácil confundir efeito do contexto de vida, agravamento ansioso e um padrão de monitoramento corporal que antecede o sono.

Adesão e mistura: Uso irregular, tomada em horários variáveis ou combinação com álcool e outros sedativos podem alterar bastante o que aparece na sessão: de sonolência marcada a noites ruins seguidas de maior irritabilidade. O paciente nem sempre espontaneamente inclui esses detalhes, sobretudo quando sente vergonha, minimiza o impacto ou entende a medicação como algo já estabilizado. Quando o padrão oscila muito de uma semana para outra, vale considerar menos uma mudança do quadro de base e mais uma variação no modo de uso.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Cloridrato de flurazepam é um benzodiazepínico hipnótico, encontrado em pacientes com queixa de insônia, sobretudo quando o sono passou a organizar a narrativa clínica e a rotina. Na sessão, o ponto central costuma ser distinguir melhora do sono de sedação residual, lentificação e uso que vai se tornando necessário para dormir. Efeitos percebidos podem aparecer já nas primeiras noites; nas primeiras 1 a 2 semanas vale observar se há sonolência diurna, piora de atenção e mudanças no padrão da sessão. Após uso contínuo por semanas, ganham peso sinais de tolerância subjetiva, adesão irregular e desconforto quando a tomada falha, o que pode se confundir com recrudescimento da ansiedade ou da própria insônia.

Perguntas úteis

- "Quando você dorme melhor, no dia seguinte se sente realmente mais descansado ou mais lento e enevado? , Nas noites em que o sono piora, isso costuma acontecer junto de preocupação, estresse ou mais quando você muda, atrasa ou esquece a medicação? , Essa dificuldade de atenção e memória aparece o dia todo ou é mais forte em certos horários da manhã e vai cedendo depois? , Quando você pensa em dormir sem esse recurso, o que aparece mais: medo de não dormir, piora concreta já observada antes, ou ambos? , Nas semanas em que você chegou mais sonolento ou mais irritado, houve uso de álcool, outra medicação para dormir ou mudança no horário habitual de tomar o remédio?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- chegar muito sedado ou mostra lentificação persistente que interfere no trabalho terapêutico e na rotina
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o impacto funcional observado
- Quando surgem esquecimentos
- confusão subjetiva ou quedas de atenção claramente acima da linha de base
- especialmente após início recente ou mudança no padrão de uso
- pode valer comunicar para avaliação clínica da tolerabilidade
- Quando o paciente descreve uso cada vez mais centrado no medo de não dormir
- com noites muito piores ao falhar a tomada e crescente apreensão em relação ao sono
- pode valer alinhar com o médico para contextualizar possível uso problemático
- Quando há combinação recorrente com álcool ou outros sedativos referida em sessão
- pode valer contato com o médico assistente pelo aumento de risco de sedação excessiva e instabilidade no funcionamento
- Quando
- após algumas semanas
- o sono segue ruim apesar do uso e a narrativa clínica fica dominada por oscilação entre sonolência diurna e insônia noturna
- pode valer comunicar para revisão do quadro e do padrão observado

Vermelho: tratar como urgência

- Paciente chega muito confuso
- excessivamente sonolento
- com fala bastante prejudicada ou dificuldade de se manter desperto na sessão.: Interromper a exploração psicoterápica
- avaliar segurança imediata

Vermelho: tratar como urgência

- acionar rede de apoio se necessário e buscar contato médico no mesmo dia; considerar emergência conforme gravidade
- Uso associado a álcool ou outros sedativos com rebaixamento importante do estado de alerta
- desorientação ou incapacidade de se deslocar com segurança.: Não deixar o paciente sair desacompanhado se houver risco
- acionar apoio imediato e encaminhar para avaliação urgente

Frase clínica

O foco clínico é separar melhora do sono de sedação residual, uso irregular e estreitamento do repertório diante do medo de não dormir.

084 ESTAZOLAM

Substância: Estazolam.

Nomes Comerciais: Noctal

Uso comum

- Estazolam é um hipnótico benzodiazepínico, geralmente encontrado em pacientes com insônia, sobretudo dificuldade para manter o sono, às vezes em contexto de ansiedade, luto, estresse agudo ou uso prolongado de sedativos. Na terapia, o mais útil é acompanhar o que muda já nos primeiros dias e na primeira ou segunda semana: melhora do sono pode coexistir com sonolência residual, lentificação, lapsos de memória e menor acesso afetivo na sessão. Também vale observar uso irregular, aumento silencioso da dependência do ritual de dormir e piora do sono ou ansiedade entre noites sem uso, o que pode confundir leitura de recaída do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sono noturno:** O paciente pode chegar relatando que dorme mais rápido ou desperta menos, mas isso nem sempre se traduz em descanso subjetivo ou melhor funcionamento diurno. Na sessão, vale notar se a melhora do sono veio acompanhada de maior organização psíquica ou apenas de apagamento noturno com manutenção de cansaço, irritabilidade e baixa tolerância. Eventos de vida, higiene do sono instável, álcool e outros sedativos podem embaralhar essa leitura, assim como noites alternadas de uso.

Sedação residual: Em parte dos pacientes aparece uma espécie de ressaca subjetiva no dia seguinte: fala mais lenta, menor espontaneidade, dificuldade de sustentar associações e redução da reatividade emocional. Isso pode ser confundido com piora depressiva, desmotivação ou resistência, especialmente se o terapeuta não conhece a linha de base anterior. Quando a lentificação varia muito entre sessões ou dentro da mesma semana, adesão irregular, horário de uso e combinação com outras substâncias entram no radar clínico.

Memória e continuidade: Alguns pacientes descrevem trechos da noite ou do início da manhã pouco nítidos, além de dificuldade para lembrar conversas, tarefas ou combinados recentes. Em sessão, isso pode aparecer como perda de continuidade do trabalho terapêutico, esquecimento de temas centrais ou relato fragmentado do que ocorreu após tomar a medicação. Privação de sono, estresse agudo e uso concomitante de álcool também podem produzir quadro parecido, então o ponto é mapear temporalidade e contexto, não concluir causalidade.

Ansiedade de rebote: Quando há noites sem uso ou uso intermitente, o paciente pode relatar piora abrupta da insônia, inquietação noturna ou ansiedade mais intensa justamente nos intervalos, o que às vezes é vivido como prova de agravamento do quadro. Na sessão, ajuda observar se a oscilação acompanha o padrão de uso mais do que acontecimentos emocionais ou conflitos em curso. Essa distinção é relevante porque o paciente pode interpretar como recaída algo que parece mais ligado à irregularidade do uso ou à dependência do ritual de dormir.

Uso prolongado: Com o tempo, o foco clínico costuma se deslocar do sintoma-alvo para a relação do paciente com a medicação: medo de não dormir sem ela, antecipação ansiosa da noite e redução da confiança em recursos próprios de regulação. Isso pode aparecer como estreitamento da vida noturna, hipervigilância com horários e maior sensibilidade a qualquer variação do sono. Mudanças recentes no trabalho, dor crônica, conflitos conjugais e outros medicamentos também podem sustentar a insônia, por isso convém não reduzir o problema ao fármaco."

O que observar em sessão

- **Sono noturno:** O paciente pode chegar relatando que dorme mais rápido ou desperta menos, mas isso nem sempre se traduz em descanso subjetivo ou melhor funcionamento diurno. Na sessão, vale notar se a melhora do sono veio acompanhada de maior organização psíquica ou apenas de apagamento noturno com manutenção de cansaço, irritabilidade e baixa tolerância. Eventos de vida, higiene do sono instável, álcool e outros sedativos podem embaralhar essa leitura, assim como noites alternadas de uso.

Sedação residual: Em parte dos pacientes aparece uma espécie de ressaca subjetiva no dia seguinte: fala mais lenta, menor espontaneidade, dificuldade de sustentar associações e redução da reatividade emocional. Isso pode ser confundido com piora depressiva, desmotivação ou resistência, especialmente se o terapeuta não conhece a linha de base anterior. Quando a lentificação varia muito entre sessões ou dentro da mesma semana, adesão irregular, horário de uso e combinação com outras substâncias entram no radar clínico.

Memória e continuidade: Alguns pacientes descrevem trechos da noite ou do início da manhã pouco nítidos, além de dificuldade para lembrar conversas, tarefas ou combinados recentes. Em sessão, isso pode aparecer como perda de continuidade do trabalho terapêutico, esquecimento de temas centrais ou relato fragmentado do que ocorreu após tomar a medicação. Privação de sono, estresse agudo e uso concomitante de álcool também podem produzir quadro parecido, então o ponto é mapear temporalidade e contexto, não concluir causalidade.

Ansiedade de rebote: Quando há noites sem uso ou uso intermitente, o paciente pode relatar piora abrupta da insônia, inquietação noturna ou ansiedade mais intensa justamente nos intervalos, o que às vezes é vivido como prova de agravamento do quadro. Na sessão, ajuda observar se a oscilação acompanha o padrão de uso mais do que acontecimentos emocionais ou conflitos em curso. Essa distinção é relevante porque o paciente pode interpretar como recaída algo que parece mais ligado à irregularidade do uso ou à dependência do ritual de dormir.

Uso prolongado: Com o tempo, o foco clínico costuma se deslocar do sintoma-alvo para a relação do paciente com a medicação: medo de não dormir sem ela, antecipação ansiosa da noite e redução da confiança em recursos próprios de regulação. Isso pode aparecer como estreitamento da vida noturna, hipervigilância com horários e maior sensibilidade a qualquer variação do sono. Mudanças recentes no trabalho, dor crônica, conflitos conjugais e outros medicamentos também podem sustentar a insônia, por isso convém não reduzir o problema ao fármaco.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Estazolam é um hipnótico benzodiazepínico, geralmente encontrado em pacientes com insônia, sobretudo dificuldade para manter o sono, às vezes em contexto de ansiedade, luto, estresse agudo ou uso prolongado de sedativos. Na terapia, o mais útil é acompanhar o que muda já nos primeiros dias e na primeira ou segunda semana: melhora do sono pode coexistir com sonolência residual, lentificação, lapsos de memória e menor acesso afetivo na sessão. Também vale observar uso irregular, aumento silencioso da dependência do ritual de dormir e piora do sono ou ansiedade entre noites sem uso, o que pode confundir leitura de recaída do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está dormindo melhor, no dia seguinte você se sente mais descansado e funcional ou mais apagado e lento? , Nas manhãs em que você acorda mais travado ou sonolento, isso costuma acontecer depois de uma noite de uso, de uma noite sem uso, ou não há um padrão claro? , Essa piora da ansiedade ou da insônia aparece ligada a algo que aconteceu na sua vida ou surge principalmente quando a noite chega e você pensa em dormir? , Você tem notado esquecimentos, trechos confusos da noite ou dificuldade para lembrar conversas e decisões do começo da manhã? , Quando imagina passar uma noite sem a medicação, o que aparece mais forte: medo de não dormir, ansiedade corporal, ou a sensação de que o sono piorou independentemente disso?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- chegar muito lentificado ou perder continuidade do processo por sonolência e esquecimento recorrentes
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o impacto funcional observado na terapia
- Quando a insônia ou a ansiedade oscilam de forma marcada entre noites de uso e noites sem uso
- pode valer comunicar para esclarecer se há um padrão de adesão irregular interferindo na leitura clínica
- Quando o paciente relata uso cada vez mais central para conseguir dormir
- com medo intenso de passar a noite sem a medicação
- pode valer alinhar com o médico pela mudança na relação com o tratamento
- Quando surgem comportamentos noturnos pouco lembrados
- confusão ao despertar ou relatos de combinações com álcool e outros sedativos
- pode valer comunicação pela relevância clínica e de segurança
- Quando
- após as primeiras uma a duas semanas
- o sono não melhora e a sessão segue dominada por sedação diurna ou prejuízo cognitivo

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer contato para compartilhar a discrepância entre alvo terapêutico e funcionamento observado

Vermelho: tratar como urgência

- Confusão importante na sessão
- dificuldade de se manter desperto
- fala muito desconexa ou rebaixamento acentuado do nível de alerta.: Interromper a exploração psicoterápica
- avaliar segurança imediata e acionar médico
- rede de apoio ou emergência conforme o contexto
- Relato de uso junto com álcool
- opioides ou outros sedativos seguido de apagões
- quedas
- comportamento desorganizado ou risco físico recente.: Tratar como situação de risco atual
- orientar busca de avaliação médica no mesmo dia e acionar rede de apoio se necessário
- Ideação suicida com plano ou impulso em contexto de intensa desesperança
- insônia grave e uso irregular do hipnótico.: Fazer manejo de risco imediatamente
- acionar psiquiatra e rede de apoio e encaminhar para emergência quando indicado

Frase clínica

O foco clínico é distinguir melhora real do sono de sedação residual, uso irregular e crescente dependência do ritual de dormir.

085 ESZOPICLONA

Substância: Eszopiclona.

Nomes Comerciais: Prysma, Ezonia, Eszopiclona, Hezo, Torrem, Soul, Eczo

Uso comum

- Eszopiclona é um hipnótico usado sobretudo para insônia, mais frequentemente quando a dificuldade principal é iniciar ou manter o sono. No consultório, o que costuma importar não é apenas se o paciente dormiu mais, mas como ele chega no dia seguinte e que lugar o remédio passou a ocupar na regulação emocional e na rotina noturna. Os efeitos percebidos tendem a aparecer já nas primeiras noites; nas primeiras 1 a 2 semanas vale observar sedação residual, lapsos de memória do período noturno e uso cada vez mais automático. Se houver interrupção abrupta após uso contínuo, pode surgir piora transitória do sono em poucos dias, o que pode se confundir com retorno do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sono e manhã seguinte:** O paciente pode relatar que adormece mais rápido ou desperta menos, mas chegar à sessão com lentificação, sonolência, fala mais arrastada ou sensação de "ressaca" ao acordar. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, exaustão por rotina ou privação de sono por eventos de vida, quando às vezes o ponto discriminativo está na qualidade da manhã seguinte em comparação com a linha de base anterior ao início do uso. Também vale notar se o ganho no sono noturno vem acompanhado de menor presença psíquica no começo do dia.

Memória noturna: Alguns pacientes descrevem trechos da noite pouco lembrados, mensagens enviadas sem recordação clara, alimentação noturna ou conversas das quais só souberam depois. Na sessão, isso pode aparecer como estranhamento, vergonha ou minimização, e pode ser confundido com distração habitual, uso de álcool, privação de sono ou conflitos domésticos mal reconstruídos. O dado clínico útil é a associação temporal entre tomar o medicamento, permanecer acordado e ter lacunas de memória ou comportamentos pouco usuais.

Uso psicológico: Com relativa rapidez, o remédio pode ganhar função psíquica além do sono: sinal de desligamento, proteção contra ruminação, recurso para encerrar o dia ou objeto de segurança sem o qual o paciente sente que "não consegue nem tentar dormir". Isso pode se misturar à própria ansiedade noturna, a hábitos de tela, horários irregulares ou medo de passar a noite em claro após experiências ruins anteriores. Na sessão, interessa observar se o uso está integrado a uma rotina mais ampla ou se passou a organizar sozinho a relação do paciente com a noite.

Adesão e rebote: Nem sempre o uso é estável: alguns pacientes alternam noites com e sem tomada, usam apenas em vésperas de compromissos ou interrompem por conta própria quando se sentem melhores ou quando temem dependência. Depois disso, uma ou duas noites muito ruins podem ser entendidas como agravamento global da insônia, quando às vezes se trata de oscilação ligada ao padrão irregular de uso. O terapeuta ganha precisão ao mapear a sequência entre noites de uso, noites sem uso e a intensidade da piora subsequente.

Segurança e contexto: Por ser um hipnótico, o contexto em que o paciente o utiliza muda bastante o que aparece na sessão: tomar e permanecer acordado, associar com álcool ou precisar levantar durante a noite aumenta a chance de experiências confusas, quedas ou condutas pouco lembradas. Esses episódios podem surgir como "coisas estranhas" em casa, conflitos com parceiro ou sensação de perda de controle, e serem atribuídos apenas ao estresse. Vale observar especialmente pacientes que moram sozinhos, têm rotina noturna imprevisível ou já apresentam vulnerabilidade cognitiva."

O que observar em sessão

- **Sono e manhã seguinte:** O paciente pode relatar que adormece mais rápido ou desperta menos, mas chegar à sessão com lentificação, sonolência, fala mais arrastada ou sensação de “ressaca” ao acordar. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, exaustão por rotina ou privação de sono por eventos de vida, quando às vezes o ponto discriminativo está na qualidade da manhã seguinte em comparação com a linha de base anterior ao início do uso. Também vale notar se o ganho no sono noturno vem acompanhado de menor presença psíquica no começo do dia.

Memória noturna: Alguns pacientes descrevem trechos da noite pouco lembrados, mensagens enviadas sem recordação clara, alimentação noturna ou conversas das quais só souberam depois. Na sessão, isso pode aparecer como estranhamento, vergonha ou minimização, e pode ser confundido com distração habitual, uso de álcool, privação de sono ou conflitos domésticos mal reconstruídos. O dado clínico útil é a associação temporal entre tomar o medicamento, permanecer acordado e ter lacunas de memória ou comportamentos pouco usuais.

Uso psicológico: Com relativa rapidez, o remédio pode ganhar função psíquica além do sono: sinal de desligamento, proteção contra ruminação, recurso para encerrar o dia ou objeto de segurança sem o qual o paciente sente que “não consegue nem tentar dormir”. Isso pode se misturar à própria ansiedade noturna, a hábitos de tela, horários irregulares ou medo de passar a noite em claro após experiências ruins anteriores. Na sessão, interessa observar se o uso está integrado a uma rotina mais ampla ou se passou a organizar sozinho a relação do paciente com a noite.

Adesão e rebote: Nem sempre o uso é estável: alguns pacientes alternam noites com e sem tomada, usam apenas em vésperas de compromissos ou interrompem por conta própria quando se sentem melhores ou quando temem dependência. Depois disso, uma ou duas noites muito ruins podem ser entendidas como agravamento global da insônia, quando às vezes se trata de oscilação ligada ao padrão irregular de uso. O terapeuta ganha precisão ao mapear a sequência entre noites de uso, noites sem uso e a intensidade da piora subsequente.

Segurança e contexto: Por ser um hipnótico, o contexto em que o paciente o utiliza muda bastante o que aparece na sessão: tomar e permanecer acordado, associar com álcool ou precisar levantar durante a noite aumenta a chance de experiências confusas, quedas ou condutas pouco lembradas. Esses episódios podem surgir como “coisas estranhas” em casa, conflitos com parceiro ou sensação de perda de controle, e serem atribuídos apenas ao estresse. Vale observar especialmente pacientes que moram sozinhos, têm rotina noturna imprevisível ou já apresentam vulnerabilidade cognitiva.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Eszopiclona é um hipnótico usado sobretudo para insônia, mais frequentemente quando a dificuldade principal é iniciar ou manter o sono. No consultório, o que costuma importar não é apenas se o paciente dormiu mais, mas como ele chega no dia seguinte e que lugar o remédio passou a ocupar na regulação emocional e na rotina noturna. Os efeitos percebidos tendem a aparecer já nas primeiras noites; nas primeiras 1 a 2 semanas vale observar sedação residual, lapsos de memória do período noturno e uso cada vez mais automático. Se houver interrupção abrupta após uso contínuo, pode surgir piora transitória do sono em poucos dias, o que pode se confundir com retorno do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que o sono melhorou, no dia seguinte você se sente mais descansado ou mais amortecido e lento do que o seu normal? , Nas noites em que algo estranho aconteceu, você se lembra com clareza do que fez depois de tomar o remédio ou ficou sabendo depois por mensagens, objetos fora do lugar ou relato de outra pessoa? , Quando a noite piora, isso aconteceu depois de alguns dias sem usar, de uso irregular, ou vem piorando mesmo mantendo o mesmo padrão de uso? , Sem o remédio, a dificuldade maior é pegar no sono, lidar com pensamentos e ansiedade da noite, ou o medo de não dormir por já ter passado noites ruins antes? , Você percebe que está usando para dormir ou também para conseguir desligar de emoções, conflitos ou ruminações do fim do dia?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve episódios noturnos com pouca ou nenhuma lembrança posterior
- pode valer alinhar com o médico assistente para avaliar segurança e relação temporal com o uso
- Quando a melhora do sono vem acompanhada de sonolência importante
- lentificação ou prejuízo funcional na manhã seguinte
- pode valer comunicar para qualificar o impacto clínico observado fora do relato de insônia
- Quando o uso se torna progressivamente mais automático
- com forte sensação de incapacidade de dormir sem o comprimido
- pode valer contato com o médico para alinhar risco de manutenção por função psicológica e abandono silencioso
- Quando há interrupções por conta própria seguidas de piora acentuada do sono em poucos dias
- pode valer comunicar para diferenciar oscilação ligada ao padrão de uso de agravamento do quadro de base
- Quando o paciente associa o uso a álcool ou relata quedas
- confusão noturna ou comportamentos de risco após tomar o medicamento
- pode valer alinhamento com o médico pela implicação de segurança

Vermelho: tratar como urgência

- Relato de dirigir
- cozinhar
- sair de casa
- cair ou realizar outras ações noturnas com lembrança parcial ou ausente após tomar o medicamento.: Tratar como situação de segurança imediata
- orientar que o paciente não permaneça sozinho com risco naquela noite se houver vulnerabilidade e acionar médico e rede de apoio no mesmo dia
- Confusão acentuada
- fala muito desconexa
- rebaixamento importante do nível de alerta ou dificuldade de se manter acordado durante a sessão.: Interromper o enquadre habitual
- avaliar necessidade de suporte imediato e acionar atendimento médico no mesmo dia
- com rede de apoio se necessário

Frase clínica

O foco clínico é distinguir melhora do sono de sedação residual, uso psicológico do hipnótico e episódios noturnos pouco lembrados.

086 FLUNITRAZEPAM

Substância: Flunitrazepam.

Nomes Comerciais: Rohypnol, Rohydorm

Uso comum

- Flunitrazepam é um benzodiazepínico hipnótico, encontrado em pacientes com queixas de insônia, ansiedade noturna ou uso prolongado de sedativos. Na sessão, o mais útil costuma ser acompanhar o que muda nas primeiras noites e na primeira ou segunda semana de uso, além do padrão que se instala quando o medicamento passa a organizar o sono de forma mais crônica. Também vale atenção a manhãs lentificadas, falhas de memória do período noturno, uso irregular e tentativas de interromper por conta própria, que podem se confundir com piora ansiosa, recaída da insônia ou desorganização por eventos de vida.

O paciente pode relatar

- **"Sono noturno:** O paciente pode chegar relatando que dorme mais rápido ou que desperta menos, mas isso nem sempre se traduz em sono percebido como restaurador. Na sessão, vale observar se houve melhora do descanso diurno ou apenas apagamento noturno com manutenção de cansaço, irritabilidade e baixa tolerância emocional. Mudanças recentes na rotina, consumo de álcool, outras medicações sedativas e noites de uso irregular podem confundir a leitura do que é efeito do medicamento, evolução da insônia de base ou oscilação situacional.

Sedação matinal: Em parte dos pacientes aparece lentificação pela manhã, fala mais arrastada, dificuldade de engatar o pensamento ou sensação de estar "grogue" nas primeiras horas do dia. Isso pode ser confundido com humor deprimido, exaustão acumulada ou retraimento defensivo, especialmente quando o paciente já vinha com baixa energia. A linha de base ajuda: se a sonolência e a redução de iniciativa surgem após noites em que o medicamento foi usado e aliviam ao longo do dia, a hipótese de efeito sedativo ganha peso observacional.

Memória e continuidade: Alguns pacientes descrevem lacunas do que fizeram ou conversaram à noite, dificuldade de lembrar do momento de deitar ou sensação de continuidade quebrada entre noite e manhã. Na sessão, isso pode aparecer como narrativa fragmentada, incerteza sobre comportamentos noturnos ou menor capacidade de elaborar experiências ocorridas após tomar o comprimido. Privação de sono, uso concomitante de álcool, estresse agudo e outras substâncias também podem produzir falhas mnésicas, por isso importa situar quando essas lacunas começaram e em que contexto aparecem.

Adesão e descontinuação: O uso pode oscilar entre noites em que o paciente toma para garantir sono e noites em que evita por receio de dependência, vergonha ou sensação de perda de controle. Esse padrão irregular frequentemente embaralha a leitura clínica: uma noite ruim pode parecer recaída da ansiedade, quando na verdade acompanha interrupção abrupta ou uso intermitente. Na sessão, vale observar se o vínculo com o medicamento está marcado por ambivalência, ocultação do padrão real de uso ou tentativas silenciosas de parar sem avisar o médico.

Ansiedade rebote: Quando o efeito noturno não se traduz em estabilidade no dia seguinte, alguns pacientes relatam manhãs mais tensas, irritabilidade, inquietação ou sensação de vulnerabilidade aumentada ao anoitecer. Isso pode ser lido como agravamento do quadro ansioso, mas às vezes aparece em torno de uso irregular, redução por conta própria ou expectativa muito alta de controle do sono. O terapeuta ganha precisão ao comparar dias consecutivos, horários em que a ansiedade piora e a relação entre noites mal dormidas, antecipação ansiosa e padrão de tomada.

Quedas e desinibição: Especialmente em pacientes mais velhos ou mais sensíveis a sedativos, podem surgir tropeços, fala pastosa, menor freio inibitório ou comportamentos noturnos pouco usuais. Na sessão, isso pode ser confundido com desorganização emocional, uso de álcool ou piora cognitiva de outra origem. O ponto clínico é notar se esses episódios se concentram após o uso noturno, se o paciente minimiza o impacto funcional e se há risco concreto em dirigir, cuidar de crianças ou circular sozinho pela manhã."

O que observar em sessão

- **Sono noturno:** O paciente pode chegar relatando que dorme mais rápido ou que desperta menos, mas isso nem sempre se traduz em sono percebido como restaurador. Na sessão, vale observar se houve melhora do descanso diurno ou apenas apagamento noturno com manutenção de cansaço, irritabilidade e baixa tolerância emocional. Mudanças recentes na rotina, consumo de álcool, outras medicações sedativas e noites de uso irregular podem confundir a leitura do que é efeito do medicamento, evolução da insônia de base ou oscilação situacional.

Sedação matinal: Em parte dos pacientes aparece lentificação pela manhã, fala mais arrastada, dificuldade de engatar o pensamento ou sensação de estar “grogue” nas primeiras horas do dia. Isso pode ser confundido com humor deprimido, exaustão acumulada ou retraimento defensivo, especialmente quando o paciente já vinha com baixa energia. A linha de base ajuda: se a sonolência e a redução de iniciativa surgem após noites em que o medicamento foi usado e aliviam ao longo do dia, a hipótese de efeito sedativo ganha peso observacional.

Memória e continuidade: Alguns pacientes descrevem lacunas do que fizeram ou conversaram à noite, dificuldade de lembrar do momento de deitar ou sensação de continuidade quebrada entre noite e manhã. Na sessão, isso pode aparecer como narrativa fragmentada, incerteza sobre comportamentos noturnos ou menor capacidade de elaborar experiências ocorridas após tomar o comprimido. Privação de sono, uso concomitante de álcool, estresse agudo e outras substâncias também podem produzir falhas mnésicas, por isso importa situar quando essas lacunas começaram e em que contexto aparecem.

Adesão e descontinuação: O uso pode oscilar entre noites em que o paciente toma para garantir sono e noites em que evita por receio de dependência, vergonha ou sensação de perda de controle. Esse padrão irregular frequentemente embaralha a leitura clínica: uma noite ruim pode parecer recaída da ansiedade, quando na verdade acompanha interrupção abrupta ou uso intermitente. Na sessão, vale observar se o vínculo com o medicamento está marcado por ambivalência, ocultação do padrão real de uso ou tentativas silenciosas de parar sem avisar o médico.

Ansiedade rebote: Quando o efeito noturno não se traduz em estabilidade no dia seguinte, alguns pacientes relatam manhãs mais tensas, irritabilidade, inquietação ou sensação de vulnerabilidade aumentada ao anoitecer. Isso pode ser lido como agravamento do quadro ansioso, mas às vezes aparece em torno de uso irregular, redução por conta própria ou expectativa muito alta de controle do sono. O terapeuta ganha precisão ao comparar dias consecutivos, horários em que a ansiedade piora e a relação entre noites mal dormidas, antecipação ansiosa e padrão de tomada.

Quedas e desinibição: Especialmente em pacientes mais velhos ou mais sensíveis a sedativos, podem surgir tropeços, fala pastosa, menor freio inibitório ou comportamentos noturnos pouco usuais. Na sessão, isso pode ser confundido com desorganização emocional, uso de álcool ou piora cognitiva de outra origem. O ponto clínico é notar se esses episódios se concentram após o uso noturno, se o paciente minimiza o impacto funcional e se há risco concreto em dirigir, cuidar de crianças ou circular sozinho pela manhã.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Flunitrazepam é um benzodiazepínico hipnótico, encontrado em pacientes com queixas de insônia, ansiedade noturna ou uso prolongado de sedativos. Na sessão, o mais útil costuma ser acompanhar o que muda nas primeiras noites e na primeira ou segunda semana de uso, além do padrão que se instala quando o medicamento passa a organizar o sono de forma mais crônica. Também vale atenção a manhãs lentificadas, falhas de memória do período noturno, uso irregular e tentativas de interromper por conta própria, que podem se confundir com piora ansiosa, recaída da insônia ou desorganização por eventos de vida.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que dormiu melhor, no dia seguinte você se sente mais descansado ou apenas mais apagado durante a noite? , Essas manhãs em que você fica mais lento ou confuso aparecem mesmo após uma noite boa de sono, ou parecem diferentes do cansaço que você já conhecia antes? , As falhas de memória acontecem em noites específicas, depois de tomar o remédio, ou também em períodos em que você dorme mal sem usá-lo? , Nos dias em que a ansiedade vem mais forte, isso costuma acontecer após noites sem tomar, após tomar em horário diferente, ou independentemente disso? , Quando você evita tomar ou tenta ficar sem, o que muda primeiro: o sono, a ansiedade do fim do dia, a irritação ou outra coisa? , Esses episódios de fala mais solta, tropeços ou atitudes pouco usuais aconteceram em contexto de bebida, privação de sono ou parecem ligados a noites em que você usou o remédio?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a alternar noites de uso e noites sem uso
- com piora importante do sono ou da ansiedade no intervalo
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer o peso da adesão irregular no quadro
- Quando surgem lentificação matinal persistente
- prejuízo funcional para trabalhar
- dirigir ou cuidar de si
- pode valer comunicar o médico para reavaliar a tolerabilidade clínica
- Quando aparecem lacunas de memória
- comportamentos noturnos pouco lembrados ou desinibição fora do padrão
- pode valer contato com o médico pela implicação em segurança e continuidade do tratamento
- Quando o paciente relata tentativa de interromper por conta própria e
- em seguida
- piora acentuada de insônia
- ansiedade ou irritabilidade
- pode valer alinhar com o médico para diferenciar descontinuação de recaída do quadro de base

Amarelo: alinhar em breve

- Quando a insônia permanece praticamente inalterada após uma a duas semanas de uso regular referido
- pode valer comunicar o médico para revisão da hipótese clínica e do manejo global

Vermelho: tratar como urgência

- Paciente chega muito sedado
- desorientado
- com fala muito pastosa
- dificuldade de se manter desperto ou relato de queda recente após uso noturno.: Interromper a sessão clínica usual
- avaliar segurança imediata e acionar médico
- familiar ou serviço de urgência conforme o contexto
- Associação com álcool ou outras substâncias depressoras do sistema nervoso central acompanhada de rebaixamento importante de consciência
- confusão intensa ou risco de acidente.: Tratar como situação de urgência
- não deixar o paciente sair desacompanhado e acionar rede de apoio e emergência quando necessário

Frase clínica

O foco clínico é distinguir sono restaurador de sedação, e recaída ansiosa de uso irregular ou interrupção por conta própria.

087 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM

Substância: Hemitartarato de Zolpidem.

Nomes Comerciais: Hemitartarato de Zolpidem, Turno SI, Turno, Riposo SI, Turno Xr, Prompt, Insonox, Zoup SI, Isoy, Zolpaz, Zolpaz SI, Zoaf, Zolfest Spray, Zolfest, Zolfest D, Zolrem SI, Noctiden, Nuit Flash, Nuit Long Xr, Patz SI, Patz Cr, Patz Gts, Zylinox SI, Stilram SI, Lune, Lune SI, Stilnox

Uso comum

- O hemitartarato de zolpidem é um hipnótico usado sobretudo para insônia, geralmente quando a queixa central é iniciar ou manter o sono. No consultório, o mais útil é acompanhar o que muda já nas primeiras noites e ao longo de 1 a 2 semanas: alguns pacientes descrevem alívio rápido da insônia, enquanto outros passam a chegar mais sonolentos, com memória fragmentada do período noturno ou uso irregular conforme a noite “pede”. Também vale atenção quando o benefício inicial perde consistência, quando o paciente amplia por conta própria o papel do remédio na rotina de sono ou quando surgem comportamentos noturnos pouco lembrados no dia seguinte. O foco clínico é diferenciar melhora do sono, sedação residual, adesão errática e agravamento do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sono noturno:** Quando funciona, o paciente tende a relatar adormecer mais rápido ou menos tempo desperto à noite, às vezes com melhora subjetiva já nos primeiros dias. Na sessão, isso pode aparecer como maior tolerância afetiva, menos exaustão e mais capacidade de elaboração, mas nem sempre significa recuperação global do quadro. Vale separar melhora do sono de uma fase de menor estresse, de exaustão acumulada ou de mudanças recentes na rotina, porque o padrão pode oscilar bastante entre noites e mascarar a leitura da baseline.

Sedação residual: Parte dos pacientes chega mais lentificada, com fala mais arrastada, atenção flutuante ou sensação de “ressaca” pela manhã. Isso pode se confundir com piora depressiva, privação de sono persistente, uso de álcool, outros sedativos ou simplesmente uma semana de maior sobrecarga. O dado mais útil costuma ser a relação temporal entre a noite anterior, o despertar e o começo do dia, observando se a lentificação é nova, intermitente ou já fazia parte do funcionamento habitual.

Memória e automatismos: Alguns pacientes descrevem lacunas de memória após tomar o medicamento, mensagens enviadas sem lembrar, alimentação noturna ou outras condutas pouco recordadas no dia seguinte. Em sessão, isso pode aparecer como estranhamento, vergonha, minimização ou dificuldade de reconstruir a sequência dos fatos. É importante não assumir causalidade de saída, porque privação de sono, álcool, outras substâncias e estados dissociativos também podem produzir narrativas fragmentadas; ainda assim, a associação com o período logo após o uso merece registro cuidadoso.

Uso irregular: Como o efeito percebido pode ser rápido, às vezes o paciente passa a usar de modo muito contingente à ansiedade da noite, alternando dias de uso, antecipando a tomada ou recorrendo ao medicamento em noites emocionalmente difíceis. No consultório, isso costuma aparecer como sensação de perda de controle sobre o próprio sono, medo de “não dormir sem ele” ou silêncio defensivo sobre a frequência real de uso. Esse padrão pode ser confundido com agravamento primário da insônia, quando na verdade a oscilação entre noites com e sem uso passa a organizar a experiência subjetiva do sono.

Descontinuação e rebote: Quando o paciente reduz ou interrompe por conta própria, pode surgir piora abrupta do sono nas noites seguintes, acompanhada de irritabilidade, ansiedade noturna ou sensação de que “voltou tudo pior”. Em sessão, isso pode ser lido como recaída do quadro ansioso ou depressivo, especialmente se a interrupção não é mencionada espontaneamente. Vale explorar a cronologia com precisão, porque um retorno muito rápido da insônia após mudança no uso sugere uma leitura diferente de uma piora mais gradual ligada a eventos de vida ou evolução do transtorno de base.

Risco comportamental: Em alguns casos, o problema central não é a insônia em si, mas o que acontece ao redor do uso: levantar à noite sem plena vigília, quedas, conflitos domésticos, exposição em mensagens ou compras, ou combinação com álcool em contextos de impulsividade. O terapeuta pode notar banalização desses episódios ou dificuldade do paciente em conectá-los ao período noturno. Aqui, a tarefa clínica é discriminar entre um incidente isolado, um padrão repetitivo e um contexto mais amplo de desorganização, uso de substâncias ou vulnerabilidade impulsiva prévia."

O que observar em sessão

- **Sono noturno:** Quando funciona, o paciente tende a relatar adormecer mais rápido ou menos tempo desperto à noite, às vezes com melhora subjetiva já nos primeiros dias. Na sessão, isso pode aparecer como maior tolerância afetiva, menos exaustão e mais capacidade de elaboração, mas nem sempre significa recuperação global do quadro. Vale separar melhora do sono de uma fase de menor estresse, de exaustão acumulada ou de mudanças recentes na rotina, porque o padrão pode oscilar bastante entre noites e mascarar a leitura da baseline.

Sedação residual: Parte dos pacientes chega mais lentificada, com fala mais arrastada, atenção flutuante ou sensação de “ressaca” pela manhã. Isso pode se confundir com piora depressiva, privação de sono persistente, uso de álcool, outros sedativos ou simplesmente uma semana de maior sobrecarga. O dado mais útil costuma ser a relação temporal entre a noite anterior, o despertar e o começo do dia, observando se a lentificação é nova, intermitente ou já fazia parte do funcionamento habitual.

Memória e automatismos: Alguns pacientes descrevem lacunas de memória após tomar o medicamento, mensagens enviadas sem lembrar, alimentação noturna ou outras condutas pouco recordadas no dia seguinte. Em sessão, isso pode aparecer como estranhamento, vergonha, minimização ou dificuldade de reconstruir a sequência dos fatos. É importante não assumir causalidade de saída, porque privação de sono, álcool, outras substâncias e estados dissociativos também podem produzir narrativas fragmentadas; ainda assim, a associação com o período logo após o uso merece registro cuidadoso.

Uso irregular: Como o efeito percebido pode ser rápido, às vezes o paciente passa a usar de modo muito contingente à ansiedade da noite, alternando dias de uso, antecipando a tomada ou recorrendo ao medicamento em noites emocionalmente difíceis. No consultório, isso costuma aparecer como sensação de perda de controle sobre o próprio sono, medo de “não dormir sem ele” ou silêncio defensivo sobre a frequência real de uso. Esse padrão pode ser confundido com agravamento primário da insônia, quando na verdade a oscilação entre noites com e sem uso passa a organizar a experiência subjetiva do sono.

Descontinuação e rebote: Quando o paciente reduz ou interrompe por conta própria, pode surgir piora abrupta do sono nas noites seguintes, acompanhada de irritabilidade, ansiedade noturna ou sensação de que “voltou tudo pior”. Em sessão, isso pode ser lido como recaída do quadro ansioso ou depressivo, especialmente se a interrupção não é mencionada espontaneamente. Vale explorar a cronologia com precisão, porque um retorno muito rápido da insônia após mudança no uso sugere uma leitura diferente de uma piora mais gradual ligada a eventos de vida ou evolução do transtorno de base.

Risco comportamental: Em alguns casos, o problema central não é a insônia em si, mas o que acontece ao redor do uso: levantar à noite sem plena vigília, quedas, conflitos domésticos, exposição em mensagens ou compras, ou combinação com álcool em contextos de impulsividade. O terapeuta pode notar banalização desses episódios ou dificuldade do paciente em conectá-los ao período noturno. Aqui, a tarefa clínica é discriminar entre um incidente isolado, um padrão repetitivo e um contexto mais amplo de desorganização, uso de substâncias ou vulnerabilidade impulsiva prévia.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O hemitartarato de zolpidem é um hipnótico usado sobretudo para insônia, geralmente quando a queixa central é iniciar ou manter o sono. No consultório, o mais útil é acompanhar o que muda já nas primeiras noites e ao longo de 1 a 2 semanas: alguns pacientes descrevem alívio rápido da insônia, enquanto outros passam a chegar mais sonolentos, com memória fragmentada do período noturno ou uso irregular conforme a noite “pede”. Também vale atenção quando o benefício inicial perde consistência, quando o paciente amplia por conta própria o papel do remédio na rotina de sono ou quando surgem comportamentos noturnos pouco lembrados no dia seguinte. O foco clínico é diferenciar melhora do sono, sedação residual, adesão errática e agravamento do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que dormiu melhor, isso apareceu como sono mais reparador no dia seguinte ou apenas como apagão mais rápido à noite? , Nas manhãs em que você fica mais lento ou grogue, isso vem depois de uma noite em que dormiu mais ou você acorda cansado como se quase não tivesse descansado? , Essas falhas de memória ou comportamentos da noite aconteceram só depois de você já estar na cama, ou também ocorrem em períodos de muito estresse ou pouco sono sem relação clara com o uso? , Quando a insônia piora, isso costuma acontecer em noites sem uso, após mudar seu jeito de usar, ou mesmo mantendo o mesmo padrão das últimas semanas? , O medo de não dormir aparece antes de deitar e leva você a se organizar em torno do remédio, ou a noite já vinha ruim por outros motivos e o uso entrou como resposta a isso? , Quando você acorda mais ansioso no dia seguinte, parece continuação de uma preocupação que já estava forte antes de dormir ou algo que surge junto com a noite mal dormida e a oscilação do uso?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar lacunas de memória
- alimentação noturna
- saídas da cama ou outros comportamentos pouco lembrados no dia seguinte
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar a segurança do uso
- Quando a sonolência matinal
- a lentificação ou a atenção muito rebaixada começam a interferir no trabalho
- em deslocamentos ou na própria sessão
- pode valer comunicar o médico pela repercussão funcional
- Quando o paciente descreve uso cada vez mais contingente à ansiedade
- com dificuldade de passar noites sem o medicamento ou ocultação da frequência real
- pode valer contato com o médico para alinhar a leitura do padrão de uso
- Quando há piora importante da insônia logo após interrupção ou mudança feita por conta própria
- pode valer comunicar o médico para diferenciar rebote

Amarelo: alinhar em breve

- adesão irregular e retorno do quadro de base
- Quando episódios noturnos se associam a álcool
- quedas
- conflitos domésticos ou outras situações de risco
- pode valer alinhamento com o médico pela necessidade de reavaliar a segurança clínica

Vermelho: tratar como urgência

- Surge relato de dirigir
- sair de casa
- cozinhar
- comer
- enviar mensagens ou realizar outras ações noturnas sem plena consciência e com pouca ou nenhuma lembrança depois.: Tratar como situação de risco no mesmo dia
- orientar medidas imediatas de proteção e acionar médico assistente e rede de apoio conforme o contexto
- O paciente chega à sessão muito confuso
- excessivamente sonolento
- descoordenado ou com suspeita de combinação recente com álcool ou outras substâncias sedativas.: Priorizar segurança imediata
- evitar que saia desacompanhado se houver risco e acionar avaliação médica no mesmo dia
- Aparecem ideias suicidas associadas a uso noturno desorganizado
- impulsividade aumentada ou contexto de rebaixamento importante da crítica e da memória.: Fazer manejo de risco suicida na hora
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

No zolpidem, o foco é separar melhora do sono de sedação residual, uso errático e comportamentos noturnos pouco lembrados.

088 LEMBorexante

Substância: Lemborexante.

Nomes Comerciais: Dayvigo

Uso comum

- Lemborexante é um hipnótico usado para insônia, sobretudo quando a queixa central é dificuldade para iniciar ou manter o sono. No consultório, o mais útil costuma ser acompanhar o que muda nas primeiras noites e nas primeiras 1 a 2 semanas: latência para dormir, despertares, sensação de sono mais contínuo e, em alguns pacientes, sonolência ao despertar ou lentificação no início do dia. Se o uso se mantém, vale observar se o ganho noturno se traduz em funcionamento diurno melhor ou se aparece um padrão de sono mais longo, inércia matinal, sonhos vívidos ou uso irregular conforme a agenda, o que pode confundir a leitura clínica.

O paciente pode relatar

- **"Sono noturno:** Pode surgir uma melhora relativamente rápida para pegar no sono ou voltar a dormir após despertares, mas nem sempre isso significa sono reparador. Na sessão, vale comparar tempo para adormecer, número de despertares e sensação subjetiva ao acordar com a linha de base anterior ao início do medicamento. Mudanças na rotina, redução de estressores, higiene do sono mais consistente ou oscilação espontânea da insônia podem produzir uma melhora parecida e confundir a atribuição ao remédio.

Manhã seguinte: Alguns pacientes chegam mais lentos, sonolentos ou com dificuldade de engrenar cognitivamente no começo do dia, enquanto outros relatam acordar melhor justamente por terem dormido mais. O ponto clínico é discriminar inércia matinal de fadiga depressiva, privação crônica de sono acumulada ou exaustão por sobrecarga de vida. Quando a lentificação aparece só nas manhãs após o uso e vai cedendo ao longo do dia, a hipótese de efeito do medicamento ganha mais peso observacional.

Sonhos e experiências noturnas: Sonhos mais vívidos, sensação de estranheza ao despertar ou lembrança aumentada do conteúdo onírico podem entrar no relato e, às vezes, mobilizar ansiedade ou evitamento de dormir. Na sessão, isso pode aparecer como apreensão com a noite, confusão entre sonho e memória recente ou aumento da vigilância antes de deitar. Também aqui convém diferenciar de piora ansiosa de base, trauma com reativação noturna, uso de outras substâncias e fragmentação do sono por fatores ambientais.

Funcionamento diurno: Quando o sono melhora, o terapeuta pode notar mais tolerância afetiva, melhor atenção e menor reatividade; em outros casos, o paciente dorme mais, mas segue sem energia, iniciativa ou clareza mental. Essa dissociação ajuda a não tomar qualquer melhora do sono como melhora global do quadro. Persistência de apatia, humor deprimido, ansiedade diurna ou prejuízo funcional apesar de noites melhores pode apontar para manutenção do transtorno de base, comorbidades ou adesão irregular.

Uso irregular: Por ser um medicamento frequentemente associado ao momento de deitar, o uso pode oscilar conforme compromissos no dia seguinte, medo de "apagar", consumo de álcool ou tentativa de usar apenas em noites consideradas piores. No consultório, isso costuma aparecer como resposta inconsistente, com noites muito diferentes entre si e dificuldade do paciente em descrever um padrão. Essa irregularidade pode se parecer com falha terapêutica, quando na verdade o dado central é a ausência de rotina estável de uso e de sono."

O que observar em sessão

- **Sono noturno:** Pode surgir uma melhora relativamente rápida para pegar no sono ou voltar a dormir após despertares, mas nem sempre isso significa sono reparador. Na sessão, vale comparar tempo para adormecer, número de despertares e sensação subjetiva ao acordar com a linha de base anterior ao início do medicamento. Mudanças na rotina, redução de estressores, higiene do sono mais consistente ou oscilação espontânea da insônia podem produzir uma melhora parecida e confundir a atribuição ao remédio.

Manhã seguinte: Alguns pacientes chegam mais lentos, sonolentos ou com dificuldade de engrenar cognitivamente no começo do dia, enquanto outros relatam acordar melhor justamente por terem dormido mais. O ponto clínico é discriminar inércia matinal de fadiga depressiva, privação crônica de sono acumulada ou exaustão por sobrecarga de vida. Quando a lentificação aparece só nas manhãs após o uso e vai cedendo ao longo do dia, a hipótese de efeito do medicamento ganha mais peso observacional.

Sonhos e experiências noturnas: Sonhos mais vívidos, sensação de estranheza ao despertar ou lembrança aumentada do conteúdo onírico podem entrar no relato e, às vezes, mobilizar ansiedade ou evitamento de dormir. Na sessão, isso pode aparecer como apreensão com a noite, confusão entre sonho e memória recente ou aumento da vigilância antes de deitar. Também aqui convém diferenciar de piora ansiosa de base, trauma com reativação noturna, uso de outras substâncias e fragmentação do sono por fatores ambientais.

Funcionamento diurno: Quando o sono melhora, o terapeuta pode notar mais tolerância afetiva, melhor atenção e menor reatividade; em outros casos, o paciente dorme mais, mas segue sem energia, iniciativa ou clareza mental. Essa dissociação ajuda a não tomar qualquer melhora do sono como melhora global do quadro. Persistência de apatia, humor deprimido, ansiedade diurna ou prejuízo funcional apesar de noites melhores pode apontar para manutenção do transtorno de base, comorbidades ou adesão irregular.

Uso irregular: Por ser um medicamento frequentemente associado ao momento de deitar, o uso pode oscilar conforme compromissos no dia seguinte, medo de “apagar”, consumo de álcool ou tentativa de usar apenas em noites consideradas piores. No consultório, isso costuma aparecer como resposta inconsistente, com noites muito diferentes entre si e dificuldade do paciente em descrever um padrão. Essa irregularidade pode se parecer com falha terapêutica, quando na verdade o dado central é a ausência de rotina estável de uso e de sono.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Lemborexante é um hipnótico usado para insônia, sobretudo quando a queixa central é dificuldade para iniciar ou manter o sono. No consultório, o mais útil costuma ser acompanhar o que muda nas primeiras noites e nas primeiras 1 a 2 semanas: latência para dormir, despertares, sensação de sono mais contínuo e, em alguns pacientes, sonolência ao despertar ou lentificação no início do dia. Se o uso se mantém, vale observar se o ganho noturno se traduz em funcionamento diurno melhor ou se aparece um padrão de sono mais longo, inércia matinal, sonhos vívidos ou uso irregular conforme a agenda, o que pode confundir a leitura clínica.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está dormindo melhor, isso aparece mais como pegar no sono mais rápido, acordar menos durante a noite ou acordar se sentindo melhor no dia seguinte? , Nos dias em que você amanhece mais lento ou grogue, isso dura só no começo da manhã ou acompanha você ao longo do dia inteiro? , Esses sonhos mais intensos ou estranhos vieram junto com o início do remédio ou já aconteciam nas fases em que sua ansiedade piorava? , Nas noites em que o efeito parece diferente, o que mudou antes de dormir: horário, álcool, tela, estresse, medo de precisar acordar cedo ou decisão de tomar ou não tomar? , Quando o sono melhora, sua atenção, humor e disposição melhoram junto ou você sente que só dormiu mais, mas continua funcionando do mesmo jeito?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente relata sonolência matinal persistente
- lentificação ou prejuízo para dirigir
- trabalhar ou cuidar de si
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar a tolerabilidade no cotidiano
- Quando há resposta muito irregular entre as noites e fica evidente um padrão de uso intermitente ou condicionado à agenda
- pode valer comunicar para contextualizar a leitura clínica de eficácia e tolerabilidade
- Quando o sono parece ter melhorado
- mas o funcionamento diurno segue bastante comprometido por humor deprimido
- ansiedade ou apatia
- pode valer alinhar com o médico para diferenciar benefício parcial de manutenção do quadro de base
- Quando surgem experiências noturnas estranhas
- confusão ao despertar ou aumento importante da apreensão com o momento de dormir após o início do uso
- pode valer comunicar para avaliação clínica mais cuidadosa
- Quando o paciente considera interromper por conta própria porque se sente grogue
- desconfortável ou sem benefício claro
- pode valer alinhar com o médico para reduzir risco de abandono silencioso e perda de seguimento

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente chega muito confuso
- excessivamente sonolento

Vermelho: tratar como urgência

- desorganizado ou sem condições de se orientar e se manter seguro.: Interromper o manejo habitual
- avaliar segurança imediata e acionar médico
- rede de apoio e emergência quando necessário no mesmo dia
- Aparecem ideação suicida aguda
- desesperança intensa ou rebaixamento importante do juízo associado a uso de álcool ou outras substâncias sedativas.: Fazer manejo de risco imediatamente
- acionar rede de apoio e encaminhar para avaliação médica urgente no mesmo dia

Frase clínica

O foco é distinguir melhora real do sono de sedação residual, uso irregular e manutenção do sofrimento diurno apesar de noites aparentemente melhores.

089 MALEATO DE MIDAZOLAM

Substância: Maleato de Midazolam.

Nomes Comerciais: Dormonid, Maleato de Midazolam

Uso comum

- Maleato de midazolam é um benzodiazepínico de ação curta, mais associado a sedação procedural, manejo agudo de ansiedade intensa e uso pontual do que a acompanhamento psicoterápico contínuo. Quando aparece no consultório, costuma ser em contexto de uso eventual, recente ou irregular, com efeitos perceptíveis no mesmo dia e pouca utilidade para observar mudança sustentada entre sessões. O foco clínico é distinguir rebaixamento de alerta, lentificação, fala empastada ou lacunas de memória de piora do quadro de base, uso de outras substâncias e adesão não compartilhada, sobretudo quando o paciente chega à sessão visivelmente diferente do seu baseline habitual.

O paciente pode relatar

- **"Sedação aguda:** Na sessão, pode aparecer sonolência, redução do tônus de alerta, fala mais lenta, dificuldade de sustentar o fio da conversa e menor capacidade de elaboração. Isso pode ser confundido com exaustão, episódio depressivo, privação de sono ou uso concomitante de álcool e outros sedativos. Vale comparar com o padrão habitual do paciente e com a proximidade temporal entre o uso e a sessão, porque a mudança tende a ser mais abrupta do que uma piora psicopatológica progressiva.

Memória e continuidade: Alguns pacientes chegam com lembrança fragmentada do que ocorreu antes da sessão ou do motivo pelo qual tomaram a medicação, o que pode empobrecer a continuidade do trabalho terapêutico naquele encontro. Em vez de assumir resistência, dissociação ou evitamento defensivo, convém observar se há lacunas circunscritas, desorientação leve ou dificuldade incomum de registrar o que foi discutido. Quando isso aparece de modo novo, o terapeuta ganha em discriminar se se trata de efeito próximo ao uso, de sobrecarga emocional ou de combinação com outras substâncias.

Uso situacional: O midazolam tende a surgir ligado a procedimentos, crises agudas ou tentativas de manejar noites muito difíceis, e isso muda o enquadre clínico: o centro nem sempre é o medicamento, mas o contexto que levou ao uso. Na sessão, pode haver alívio pontual sem elaboração correspondente, ou um contraste entre sofrimento intenso fora dali e apresentação mais amortecida no consultório. Isso pode confundir a leitura da gravidade real do quadro se o terapeuta não explorar quando, para quê e em que circunstância o uso ocorreu.

Adesão e não revelação: Por ser um medicamento de uso muitas vezes episódico, o paciente pode não considerá-lo relevante e omitir que tomou antes da sessão ou em dias recentes. O terapeuta pode notar mudança súbita no nível de alerta, menor responsividade emocional ou inconsistência entre conteúdo relatado e presença psíquica disponível. Nesses casos, a questão clínica não é apenas adesão, mas também a qualidade da informação compartilhada, já que o uso não mencionado pode distorcer a leitura do processo e da segurança naquele encontro.

Risco comportamental: Quando o paciente chega muito sedado, desorganizado ou com julgamento aparentemente rebaixado, a preocupação clínica imediata deixa de ser o conteúdo interpretativo da sessão e passa a ser segurança. Isso pode se confundir com intoxicação por álcool, uso de outras drogas, privação extrema de sono ou condição médica intercorrente. A observação prudente do estado geral, da coerência da fala e da capacidade de se orientar e sair em segurança do consultório é mais útil do que tentar extrair material psicodinâmico de um encontro com pouca condição de trabalho."

O que observar em sessão

- **Sedação aguda:** Na sessão, pode aparecer sonolência, redução do tônus de alerta, fala mais lenta, dificuldade de sustentar o fio da conversa e menor capacidade de elaboração. Isso pode ser confundido com exaustão, episódio depressivo, privação de sono ou uso concomitante de álcool e outros sedativos. Vale comparar com o padrão habitual do paciente e com a proximidade temporal entre o uso e a sessão, porque a mudança tende a ser mais abrupta do que uma piora psicopatológica progressiva.

Memória e continuidade: Alguns pacientes chegam com lembrança fragmentada do que ocorreu antes da sessão ou do motivo pelo qual tomaram a medicação, o que pode empobrecer a continuidade do trabalho terapêutico naquele encontro. Em vez de assumir resistência, dissociação ou evitamento defensivo, convém observar se há lacunas circunscritas, desorientação leve ou dificuldade incomum de registrar o que foi discutido. Quando isso aparece de modo novo, o terapeuta ganha em discriminar se se trata de efeito próximo ao uso, de sobrecarga emocional ou de combinação com outras substâncias.

Uso situacional: O midazolam tende a surgir ligado a procedimentos, crises agudas ou tentativas de manejar noites muito difíceis, e isso muda o enquadre clínico: o centro nem sempre é o medicamento, mas o contexto que levou ao uso. Na sessão, pode haver alívio pontual sem elaboração correspondente, ou um contraste entre sofrimento intenso fora dali e apresentação mais amortecida no consultório. Isso pode confundir a leitura da gravidade real do quadro se o terapeuta não explorar quando, para quê e em que circunstância o uso ocorreu.

Adesão e não revelação: Por ser um medicamento de uso muitas vezes episódico, o paciente pode não considerá-lo relevante e omitir que tomou antes da sessão ou em dias recentes. O terapeuta pode notar mudança súbita no nível de alerta, menor responsividade emocional ou inconsistência entre conteúdo relatado e presença psíquica disponível. Nesses casos, a questão clínica não é apenas adesão, mas também a qualidade da informação compartilhada, já que o uso não mencionado pode distorcer a leitura do processo e da segurança naquele encontro.

Risco comportamental: Quando o paciente chega muito sedado, desorganizado ou com julgamento aparentemente rebaixado, a preocupação clínica imediata deixa de ser o conteúdo interpretativo da sessão e passa a ser segurança. Isso pode se confundir com intoxicação por álcool, uso de outras drogas, privação extrema de sono ou condição médica intercorrente. A observação prudente do estado geral, da coerência da fala e da capacidade de se orientar e sair em segurança do consultório é mais útil do que tentar extrair material psicodinâmico de um encontro com pouca condição de trabalho.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Maleato de midazolam é um benzodiazepínico de ação curta, mais associado a sedação procedural, manejo agudo de ansiedade intensa e uso pontual do que a acompanhamento psicoterápico contínuo. Quando aparece no consultório, costuma ser em contexto de uso eventual, recente ou irregular, com efeitos perceptíveis no mesmo dia e pouca utilidade para observar mudança sustentada entre sessões. O foco clínico é distinguir rebaixamento de alerta, lentificação, fala empastada ou lacunas de memória de piora do quadro de base, uso de outras substâncias e adesão não compartilhada, sobretudo quando o paciente chega à sessão visivelmente diferente do seu baseline habitual.

Perguntas úteis

- "Hoje você se sente sonolento ou mais lento de um jeito diferente do seu cansaço habitual? , Essa dificuldade para lembrar ou organizar o que aconteceu começou depois de algum uso pontual ou já vinha aparecendo antes? , O que levou você a usar essa medicação nessa ocasião: um procedimento, uma crise específica, dificuldade para dormir ou outra situação? , Quando você chega mais amortecido, isso parece combinar com alívio do sofrimento ou com uma espécie de apagamento que atrapalha pensar e lembrar? , Essa mudança que estou vendo hoje aconteceu de forma súbita nas últimas horas ou vem se acumulando ao longo de dias? , Além dessa medicação, houve álcool ou outra substância nas últimas horas que possa ter mudado como você está aqui agora?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente à sessão com sedação evidente
- lentificação importante ou lacunas de memória
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer o contexto de uso e o impacto funcional
- Quando surge uso não compartilhado
- irregular ou em situações fora do padrão previamente conhecido
- pode valer comunicar para reduzir ruído clínico e risco de manejo inadequado do sofrimento
- Quando o paciente descreve combinação com álcool ou outras substâncias sedativas
- pode valer contato com o médico pela implicação de segurança e pela dificuldade de interpretar o estado mental na sessão
- Quando há piora importante da capacidade de atenção
- memória ou orientação após uso recente
- pode valer alinhar com o médico para diferenciar efeito agudo
- interação medicamentosa ou outra intercorrência
- Quando o medicamento aparece como recurso frequente para lidar com crises sem melhora sustentada entre sessões
- pode valer comunicar o médico para integrar a leitura clínica do padrão de uso e do sofrimento de base

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente apresenta rebaixamento importante do nível de consciência
- dificuldade de se manter desperto
- fala muito empastada ou incapacidade de se orientar adequadamente.: Interromper o trabalho clínico
- priorizar segurança imediata e acionar suporte médico de urgência
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Surge uso associado a álcool ou outras substâncias sedativas com comprometimento visível do estado mental na sessão.: Tratar como situação de risco agudo
- não deixar o paciente sair desacompanhado se houver prejuízo importante e acionar avaliação médica imediata conforme o contexto

Frase clínica

Com midazolam, o essencial é diferenciar sedação e lacunas de memória de mudança psicopatológica real e priorizar segurança quando o paciente chega rebaixado.

090 NITRAZEPAM

Substância: Nitrazepam.

Nomes Comerciais: Nitrapan, Nitrazepam (Port 344/98 Lista B1), Sonebon

Uso comum

- Nitrazepam é um benzodiazepínico de perfil hipnótico, encontrado em pacientes com queixas de insônia, ansiedade noturna ou uso prolongado de medicação para dormir. Na terapia, o mais útil costuma ser acompanhar o que muda já nos primeiros dias de uso - sobretudo sonolência residual, lentificação e alteração da qualidade do despertar - e, quando o uso se prolonga por semanas ou meses, observar dependência do ritual medicamentoso, perda de espontaneidade do sono e dificuldade para diferenciar insônia de base, ansiedade antecipatória e efeito de uso irregular. Mudanças abruptas no padrão de uso podem repercutir rapidamente, às vezes em 1 a 3 dias.

O paciente pode relatar

- **"Sono e despertar:** O paciente pode relatar que dorme mais rápido, mas acorda com sensação de sono pesado, cabeça lenta ou dificuldade para se engajar pela manhã. Em sessão, isso às vezes aparece como fala mais arrastada, menor vivacidade associativa ou dificuldade de acessar material emocional logo no início. A leitura pode se confundir com privação crônica de sono, piora depressiva, rotina desorganizada ou uso concomitante de outras substâncias sedativas, então vale comparar com a linha de base anterior ao início ou à mudança do padrão de uso.

Sedação diurna: Parte dos pacientes chega mais sonolenta, com atenção flutuante, menor velocidade de pensamento e redução da iniciativa, especialmente quando a sessão ocorre cedo ou após noites de uso mais regular. Isso pode ser lido apressadamente como retraimento depressivo, resistência, desinvestimento do processo ou baixa motivação. A discriminação clínica melhora quando se observa a variação ao longo do dia, a relação com o horário da tomada e a diferença entre cansaço subjetivo e humor deprimido propriamente dito.

Memória e elaboração: Pode haver empobrecimento do registro fino da semana, lapsos de memória recente ou dificuldade de sustentar encadeamentos mais complexos na sessão. O terapeuta pode notar menor capacidade de simbolização em comparação com o baseline, sem que isso signifique necessariamente piora estrutural do quadro. Também entram como confundidores a própria insônia, estresse agudo, uso de álcool, outros sedativos e flutuações atencionais que já existiam antes do medicamento.

Ansiedade noturna: Às vezes o paciente descreve alívio do estado de alerta noturno sem mudança equivalente na ansiedade diurna, o que ajuda a separar sofrimento ligado ao momento de deitar de um quadro ansioso mais difuso. Em outros casos, a melhora do sono convive com manutenção de ruminação, tensão corporal e evitação durante o dia, e a sessão pode mostrar que o núcleo do problema segue ativo apesar de noites aparentemente melhores. Também vale considerar eventos de vida recentes e hábitos de sono, para não atribuir toda oscilação ao medicamento.

Uso habitual e adesão: Com o passar do tempo, alguns pacientes passam a organizar a noite em torno da medicação e ficam mais inseguros diante da possibilidade de dormir sem ela, mesmo quando não descrevem piora global do quadro. Na sessão, isso pode aparecer como apego ao ritual, uso em horários variáveis, esquecimento seguido de compensações improvisadas ou omissão por vergonha. Esse campo se confunde facilmente com insônia condicionada, ansiedade antecipatória e tentativas autônomas de ajustar o uso sem comunicar ao médico.

Interrupção e rebote: Quando há redução irregular, esquecimento de noites seguidas ou interrupção por conta própria, podem surgir rapidamente piora do sono, irritabilidade, ansiedade mais intensa e sensação de estranhamento corporal. Em sessão, o risco é ler isso como recaída integral do quadro de base, quando às vezes a cronologia sugere relação com mudança recente no padrão de uso. A chave costuma estar menos na intensidade isolada dos sintomas e mais no aparecimento abrupto após noites sem a medicação."

O que observar em sessão

- **Sono e despertar:** O paciente pode relatar que dorme mais rápido, mas acorda com sensação de sono pesado, cabeça lenta ou dificuldade para se engajar pela manhã. Em sessão, isso às vezes aparece como fala mais arrastada, menor vivacidade associativa ou dificuldade de acessar material emocional logo no início. A leitura pode se confundir com privação crônica de sono, piora depressiva, rotina desorganizada ou uso concomitante de outras substâncias sedativas, então vale comparar com a linha de base anterior ao início ou à mudança do padrão de uso.

Sedação diurna: Parte dos pacientes chega mais sonolenta, com atenção flutuante, menor velocidade de pensamento e redução da iniciativa, especialmente quando a sessão ocorre cedo ou após noites de uso mais regular. Isso pode ser lido apressadamente como retraimento depressivo, resistência, desinvestimento do processo ou baixa motivação. A discriminação clínica melhora quando se observa a variação ao longo do dia, a relação com o horário da tomada e a diferença entre cansaço subjetivo e humor deprimido propriamente dito.

Memória e elaboração: Pode haver empobrecimento do registro fino da semana, lapsos de memória recente ou dificuldade de sustentar encadeamentos mais complexos na sessão. O terapeuta pode notar menor capacidade de simbolização em comparação com o baseline, sem que isso signifique necessariamente piora estrutural do quadro. Também entram como confundidores a própria insônia, estresse agudo, uso de álcool, outros sedativos e flutuações atencionais que já existiam antes do medicamento.

Ansiedade noturna: Às vezes o paciente descreve alívio do estado de alerta noturno sem mudança equivalente na ansiedade diurna, o que ajuda a separar sofrimento ligado ao momento de deitar de um quadro ansioso mais difuso. Em outros casos, a melhora do sono convive com manutenção de ruminação, tensão corporal e evitação durante o dia, e a sessão pode mostrar que o núcleo do problema segue ativo apesar de noites aparentemente melhores. Também vale considerar eventos de vida recentes e hábitos de sono, para não atribuir toda oscilação ao medicamento.

Uso habitual e adesão: Com o passar do tempo, alguns pacientes passam a organizar a noite em torno da medicação e ficam mais inseguros diante da possibilidade de dormir sem ela, mesmo quando não descrevem piora global do quadro. Na sessão, isso pode aparecer como apego ao ritual, uso em horários variáveis, esquecimento seguido de compensações improvisadas ou omissão por vergonha. Esse campo se confunde facilmente com insônia condicionada, ansiedade antecipatória e tentativas autônomas de ajustar o uso sem comunicar ao médico.

Interrupção e rebote: Quando há redução irregular, esquecimento de noites seguidas ou interrupção por conta própria, podem surgir rapidamente piora do sono, irritabilidade, ansiedade mais intensa e sensação de estranhamento corporal. Em sessão, o risco é ler isso como recaída integral do quadro de base, quando às vezes a cronologia sugere relação com mudança recente no padrão de uso. A chave costuma estar menos na intensidade isolada dos sintomas e mais no aparecimento abrupto após noites sem a medicação.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Nitrazepam é um benzodiazepínico de perfil hipnótico, encontrado em pacientes com queixas de insônia, ansiedade noturna ou uso prolongado de medicação para dormir. Na terapia, o mais útil costuma ser acompanhar o que muda já nos primeiros dias de uso - sobretudo sonolência residual, lentificação e alteração da qualidade do despertar - e, quando o uso se prolonga por semanas ou meses, observar dependência do ritual medicamentoso, perda de espontaneidade do sono e dificuldade para diferenciar insônia de base, ansiedade antecipatória e efeito de uso irregular. Mudanças abruptas no padrão de uso podem repercutir rapidamente, às vezes em 1 a 3 dias.

Perguntas úteis

- "Quando você acorda pior no dia seguinte, isso se parece mais com sono não reparador, com tristeza/desânimo, ou com uma sensação de corpo e mente ainda "desligados"? , Nas noites em que você não usa, esquece ou muda o horário, o que acontece de diferente no seu sono e no dia seguinte em comparação com as noites habituais? , Quando você diz que está mais ansioso à noite, isso começa antes de deitar, na tentativa de pegar no sono, ou já vem ao longo do dia inteiro? , Essa dificuldade de lembrar a semana ou de organizar o pensamento apareceu junto com a piora do sono, com o início do remédio, ou já era um padrão seu antes? , Quando você pensa em dormir sem a medicação, o que aparece mais forte: medo de não dormir, sensação física de alerta, ou a ideia de que a noite vai sair do controle?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente muito sedado
- com prejuízo claro de atenção
- memória ou funcionamento diurno
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar o impacto clínico desse padrão no cotidiano
- Quando surgem esquecimentos frequentes
- uso em horários muito variáveis ou interrupções por conta própria seguidas de piora abrupta do sono e da ansiedade
- pode valer comunicar o médico para esclarecer se há um padrão de adesão irregular interferindo na leitura do caso
- Quando a melhora do início do sono convive com manutenção importante de sofrimento psíquico
- ruminação ou prejuízo funcional após algumas semanas
- pode valer alinhar com o médico para evitar que o ganho parcial no sono masque a evolução do quadro de base
- Quando o paciente passa a demonstrar dependência subjetiva intensa do ritual medicamentoso
- com medo acentuado de dormir sem ele e crescente estreitamento da autonomia noturna
- pode valer compartilhar essa observação clínica com o médico assistente

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente chega muito rebaixado
- confuso
- com fala bastante pastosa
- dificuldade marcante de se manter desperto ou relato de queda/acidente recente associado a sedação.: Interromper o foco habitual da sessão
- avaliar segurança imediata e acionar médico
- rede de apoio ou emergência conforme a gravidade do quadro
- Aparecem ideação suicida aguda
- desesperança intensa ou comportamento de risco em contexto de uso irregular
- associação com álcool ou piora abrupta do estado mental.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

O foco clínico é separar melhora do início do sono de sedação residual, uso habitual e piora rápida após mudanças irregulares no padrão de uso.

091 ZOPICLONA

Substância: Zopiclona.

Nomes Comerciais: Imovane

Uso comum

- Zopiclona é um hipnótico usado sobretudo para insônia, geralmente quando a dificuldade principal é iniciar ou manter o sono. No consultório, o mais útil é acompanhar o que muda já nas primeiras noites e na primeira semana: melhora do adormecer pode coexistir com sonolência residual, lentificação matinal, lapsos de memória do período noturno e uso mais frequente do que o combinado. Após algumas semanas, ganha peso clínico distinguir benefício sustentado de uso por hábito, aumento da preocupação em dormir e piora do sono quando a tomada falha. O foco da sessão costuma ser a relação entre sono, funcionamento no dia seguinte e padrão de uso real.

O paciente pode relatar

- **"Sono e manhã seguinte:** O paciente pode chegar descrevendo que dorme mais rápido ou desperta menos, mas também com sensação de sono não reparador, cabeça pesada ao acordar ou dificuldade de engrenar pela manhã. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais lenta, bocejos, menor acesso associativo e redução da responsividade, o que às vezes se confunde com piora depressiva, exaustão acumulada ou privação de sono por rotina irregular. Vale observar se a lentificação se concentra no início do dia e melhora ao longo das horas, o que ajuda a separar efeito residual noturno de rebaixamento global do humor ou da energia.

Memória e automatismos: Alguns pacientes relatam trechos da noite pouco lembrados, mensagens enviadas sem recordação clara, alimentação noturna ou conversas das quais só souberam depois. Em sessão, isso pode surgir como narrativa fragmentada, estranhamento com o próprio comportamento ou minimização por vergonha, e pode ser confundido com distração habitual, uso concomitante de álcool ou outros sedativos, ou episódios dissociativos. O ponto clínico é situar temporalmente esses eventos em relação à tomada e ao período logo antes de dormir, sem assumir causalidade automática.

Uso por hábito: Com o passar das semanas, às vezes o medicamento deixa de aparecer apenas como recurso para dormir e passa a organizar a noite do paciente, com ansiedade antecipatória quando não está disponível. Na sessão, isso pode se mostrar como rigidez de rotina, medo intenso de não apagar e pouca exploração de fatores emocionais ou comportamentais ligados à insônia, o que pode ser confundido com gravidade do quadro de base ou fase aguda de estresse. Também vale considerar adesão irregular: alternância entre noites com uso, sem uso e uso em horários diferentes costuma embaralhar a leitura do sono e do funcionamento diurno.

Ansiedade noturna: Quando a zopiclona entra em cena, parte da ansiedade ligada ao deitar pode diminuir, mas nem sempre isso significa redução mais ampla da ansiedade ao longo do dia. O terapeuta pode notar alívio restrito ao momento de dormir, enquanto ruminação, hiperalerta e tensão seguem presentes em outros horários, o que ajuda a diferenciar melhora do sono de melhora do quadro ansioso. Em outros casos, a própria preocupação em conseguir dormir passa a dominar a sessão e pode mascarar conflitos, lutos ou sobrecarga recente que continuam alimentando a insônia.

Adesão e interrupções: Mudanças bruscas no padrão de sono após noites sem tomar, uso em horários muito variáveis ou retomadas pontuais depois de interrupção podem aparecer como o remédio parou de funcionar ou minha insônia voltou pior. Na sessão, o terapeuta pode encontrar oscilação importante entre encontros, com um paciente mais sedado em uma semana e mais agitado ou exausto na outra, sem que isso reflita necessariamente mudança do quadro psíquico de base. Registrar o padrão real de uso ajuda a diferenciar efeito residual, rebote de insônia e impacto de eventos de vida sobre o sono."

O que observar em sessão

- **Sono e manhã seguinte:** O paciente pode chegar descrevendo que dorme mais rápido ou desperta menos, mas também com sensação de sono não reparador, cabeça "pesada" ao acordar ou dificuldade de engrenar pela manhã. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais lenta, bocejos, menor acesso associativo e redução da responsividade, o que às vezes se confunde com piora depressiva, exaustão acumulada ou privação de sono por rotina irregular. Vale observar se a lentificação se concentra no início do dia e melhora ao longo das horas, o que ajuda a separar efeito residual noturno de rebaixamento global do humor ou da energia.

Memória e automatismos: Alguns pacientes relatam trechos da noite pouco lembrados, mensagens enviadas sem recordação clara, alimentação noturna ou conversas das quais só souberam depois. Em sessão, isso pode surgir como narrativa fragmentada, estranhamento com o próprio comportamento ou minimização por vergonha, e pode ser confundido com distração habitual, uso concomitante de álcool ou outros sedativos, ou episódios dissociativos. O ponto clínico é situar temporalmente esses eventos em relação à tomada e ao período logo antes de dormir, sem assumir causalidade automática.

Uso por hábito: Com o passar das semanas, às vezes o medicamento deixa de aparecer apenas como recurso para dormir e passa a organizar a noite do paciente, com ansiedade antecipatória quando não está disponível. Na sessão, isso pode se mostrar como rigidez de rotina, medo intenso de "não apagar" e pouca exploração de fatores emocionais ou comportamentais ligados à insônia, o que pode ser confundido com gravidade do quadro de base ou fase aguda de estresse. Também vale considerar adesão irregular: alternância entre noites com uso, sem uso e uso em horários diferentes costuma embaralhar a leitura do sono e do funcionamento diurno.

Ansiedade noturna: Quando a zopiclona entra em cena, parte da ansiedade ligada ao deitar pode diminuir, mas nem sempre isso significa redução mais ampla da ansiedade ao longo do dia. O terapeuta pode notar alívio restrito ao momento de dormir, enquanto ruminação, hiperalerta e tensão seguem presentes em outros horários, o que ajuda a diferenciar melhora do sono de melhora do quadro ansioso. Em outros casos, a própria preocupação em conseguir dormir passa a dominar a sessão e pode mascarar conflitos, lutos ou sobrecarga recente que continuam alimentando a insônia.

Adesão e interrupções: Mudanças bruscas no padrão de sono após noites sem tomar, uso em horários muito variáveis ou retomadas pontuais depois de interrupção podem aparecer como "o remédio parou de funcionar" ou "minha insônia voltou pior". Na sessão, o terapeuta pode encontrar oscilação importante entre encontros, com um paciente mais sedado em uma semana e mais agitado ou exausto na outra, sem que isso reflita necessariamente mudança do quadro psíquico de base. Registrar o padrão real de uso ajuda a diferenciar efeito residual, rebote de insônia e impacto de eventos de vida sobre o sono.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Zopiclona é um hipnótico usado sobretudo para insônia, geralmente quando a dificuldade principal é iniciar ou manter o sono. No consultório, o mais útil é acompanhar o que muda já nas primeiras noites e na primeira semana: melhora do adormecer pode coexistir com sonolência residual, lentificação matinal, lapsos de memória do período noturno e uso mais frequente do que o combinado. Após algumas semanas, ganha peso clínico distinguir benefício sustentado de uso por hábito, aumento da preocupação em dormir e piora do sono quando a tomada falha. O foco da sessão costuma ser a relação entre sono, funcionamento no dia seguinte e padrão de uso real.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está pior no dia seguinte, isso aparece como sono e lentidão ao acordar ou como tristeza e desânimo que atravessam o dia inteiro? , Nas noites em que o sono falha, o que muda: você não consegue desligar a cabeça, sente o corpo acelerado, ou percebe que ficou sem tomar ou tomou em horário diferente? , Esses episódios de não lembrar bem o que fez à noite aconteceram perto de ir para a cama e depois de tomar o remédio, ou também já aconteciam em outros contextos? , Quando você pensa em dormir sem a medicação, o que aparece mais forte: medo de passar a noite em claro, ansiedade física, ou a sensação de que sua rotina da noite desorganiza completamente? , Nos dias em que você dorme melhor, você se sente realmente mais disponível e funcional ou apenas mais apagado e menos reativo? , As oscilações do seu sono nesta semana combinaram mais com algo da sua rotina e do que aconteceu na vida, ou com mudanças no jeito real de usar a medicação?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve sonolência residual frequente
- lentificação importante pela manhã ou prejuízo funcional recorrente no dia seguinte
- pode valer alinhar com o médico assistente para qualificar tolerabilidade e impacto no cotidiano
- Quando surgem episódios de comportamentos noturnos com lembrança parcial ou ausente
- especialmente se envolvem sair de casa
- cozinhar
- comer ou enviar mensagens sem recordação clara
- pode valer comunicar o médico pela relevância de segurança
- Quando o uso passa a ocorrer em mais noites do que o paciente inicialmente relatava
- com ansiedade marcada diante da possibilidade de ficar sem o medicamento
- pode valer contato com o médico para alinhar padrão de uso e risco de abandono silencioso do acompanhamento
- Quando o paciente alterna noites de uso e não uso com piora importante do sono e do funcionamento
- pode valer comunicar o médico para diferenciar adesão irregular
- rebote de insônia e persistência do quadro de base

Amarelo: alinhar em breve

- Quando não há ganho perceptível no sono após os primeiros dias a uma semana
- apesar de uso aparentemente regular
- pode valer alinhar com o médico para revisar a leitura clínica do que está sustentando a queixa

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente relata ter dirigido
- saído de casa
- cozinhado ou realizado outras ações complexas à noite sem lembrança clara do que fez.: Avalie segurança imediata
- oriente a não permanecer sozinho se houver risco concreto e busque contato com o médico assistente no mesmo dia; acione rede de apoio ou emergência se necessário
- Na sessão
- há rebaixamento acentuado de consciência
- fala muito arrastada
- confusão importante ou dificuldade de se manter desperto.: Interrompa a exploração psicoterápica
- priorize segurança
- verifique possibilidade de uso concomitante de álcool ou outros sedativos e acione avaliação médica no mesmo dia

Frase clínica

Com zopiclona, o foco clínico é separar melhora do sono de sedação residual, automatismos noturnos e uso que passa de recurso a eixo da noite.

092 CRATAEGUS RHIPIDOPHYLLA GAND.;PASSIFLORA INCARNATA;SALIX ALBA L.

Substância: Crataegus Rhipidophylla Gand.;Passiflora Incarnata;Salix Alba L..

Nomes Comerciais: Pasalix, Serenus

Uso comum

- Associação fitoterápica usada, em geral, em contextos de nervosismo, tensão subjetiva e dificuldade para desacelerar, às vezes por iniciativa própria do paciente e sem acompanhamento médico contínuo. No consultório, costuma aparecer mais como pano de fundo do manejo de ansiedade leve, insônia inicial ou agitação situacional do que como eixo central do caso. Não há uma janela terapêutica tão nítida quanto a de psicofármacos de uso comum; vale observar o que muda nos primeiros dias e ao longo de 1 a 2 semanas, sobretudo sedação, lentificação, sensação de “acalmar” e uso irregular conforme a demanda. O ponto central na sessão é discriminar alívio inespecífico, efeito sedativo, flutuação do estresse e automanejo intermitente.

O paciente pode relatar

- **"Sedação discreta:** Alguns pacientes chegam mais lentos, sonolentos ou com menor vivacidade associativa, especialmente quando usam o fitoterápico em momentos de maior tensão ou à noite e mantêm efeito residual na sessão seguinte. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento ou resistência, quando às vezes se aproxima mais de um rebaixamento inespecífico do estado de alerta. Também convém considerar privação de sono, outras substâncias com efeito sedativo e variações do próprio ritmo do paciente.

Ansiedade situacional: Quando há benefício percebido, ele tende a aparecer como redução da urgência interna, menor aceleração e mais tolerância ao desconforto em situações específicas, sem necessariamente alterar o padrão ansioso de base. Na sessão, isso pode se confundir com melhora clínica mais ampla ou, ao contrário, mascarar a persistência de ruminação, evitação e hipervigilância. A leitura fica mais precisa quando se diferencia o que mudou no corpo e no ritmo imediato do que mudou na organização psíquica diante dos mesmos gatilhos.

Sono e rotina: O uso pode entrar no relato ligado a dificuldade para iniciar o sono, despertares após dias tensos ou tentativa de "desligar" no fim do dia. Se o paciente dorme melhor, a sessão pode ganhar mais disponibilidade afetiva e cognitiva; se acorda pesado, pode surgir lentificação, irritabilidade ou sensação de ressaca subjetiva. Mudanças recentes na rotina, cafeína, álcool, telas e horários irregulares frequentemente confundem a atribuição do que está acontecendo.

Uso intermitente: Como se trata de um produto frequentemente manejado pelo próprio paciente, é comum uso irregular, em dias mais difíceis, em horários variáveis ou sem registro claro de frequência. Isso pode produzir uma narrativa de eficácia instável, em que o paciente atribui ao produto tanto melhoras quanto frustrações que acompanham oscilações do contexto. Na sessão, vale observar se há um padrão de automanejo reativo ao estresse, mais do que um efeito consistente ao longo do tempo."

O que observar em sessão

- **Sedação discreta:** Alguns pacientes chegam mais lentos, sonolentos ou com menor vivacidade associativa, especialmente quando usam o fitoterápico em momentos de maior tensão ou à noite e mantêm efeito residual na sessão seguinte. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento ou resistência, quando às vezes se aproxima mais de um rebaixamento inespecífico do estado de alerta. Também convém considerar privação de sono, outras substâncias com efeito sedativo e variações do próprio ritmo do paciente.

Ansiedade situacional: Quando há benefício percebido, ele tende a aparecer como redução da urgência interna, menor aceleração e mais tolerância ao desconforto em situações específicas, sem necessariamente alterar o padrão ansioso de base. Na sessão, isso pode se confundir com melhora clínica mais ampla ou, ao contrário, mascarar a persistência de ruminação, evitação e hipervigilância. A leitura fica mais precisa quando se diferencia o que mudou no corpo e no ritmo imediato do que mudou na organização psíquica diante dos mesmos gatilhos.

Sono e rotina: O uso pode entrar no relato ligado a dificuldade para iniciar o sono, despertares após dias tensos ou tentativa de “desligar” no fim do dia. Se o paciente dorme melhor, a sessão pode ganhar mais disponibilidade afetiva e cognitiva; se acorda pesado, pode surgir lentificação, irritabilidade ou sensação de ressaca subjetiva. Mudanças recentes na rotina, cafeína, álcool, telas e horários irregulares frequentemente confundem a atribuição do que está acontecendo.

Uso intermitente: Como se trata de um produto frequentemente manejado pelo próprio paciente, é comum uso irregular, em dias mais difíceis, em horários variáveis ou sem registro claro de frequência. Isso pode produzir uma narrativa de eficácia instável, em que o paciente atribui ao produto tanto melhoras quanto frustrações que acompanham oscilações do contexto. Na sessão, vale observar se há um padrão de automanejo reativo ao estresse, mais do que um efeito consistente ao longo do tempo.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Associação fitoterápica usada, em geral, em contextos de nervosismo, tensão subjetiva e dificuldade para desacelerar, às vezes por iniciativa própria do paciente e sem acompanhamento médico contínuo. No consultório, costuma aparecer mais como pano de fundo do manejo de ansiedade leve, insônia inicial ou agitação situacional do que como eixo central do caso. Não há uma janela terapêutica tão nítida quanto a de psicofármacos de uso comum; vale observar o que muda nos primeiros dias e ao longo de 1 a 2 semanas, sobretudo sedação, lentificação, sensação de “acalmar” e uso irregular conforme a demanda. O ponto central na sessão é discriminar alívio inespecífico, efeito sedativo, flutuação do estresse e automanejo intermitente.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que ficou mais calmo, isso apareceu como menos preocupação por dentro ou mais como sono, corpo pesado e menor aceleração? , Nos dias em que você usa, o que muda de forma mais nítida: o início do sono, a tensão no corpo, os pensamentos repetitivos ou quase nada disso? , Quando você chega mais lento ou menos espontâneo, isso se parece com cansaço e sonolência ou com desânimo e perda de interesse que já vinham antes? , Você percebe diferença entre dias em que toma por prevenção e dias em que toma só quando já está muito tenso? , Quando a ansiedade diminui, você continua evitando as mesmas situações e ruminando depois, ou sente que consegue enfrentá-las de outro modo?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve uso muito frequente
- pouco claro ou combinado com outras substâncias para dormir ou se acalmar
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer o contexto de uso e reduzir leituras confusas do quadro
- Quando surge sonolência persistente
- identificação ou prejuízo funcional que o paciente associa temporalmente ao início do fitoterápico
- pode valer comunicar ao médico para avaliação da tolerabilidade no contexto clínico global
- Quando o paciente aposta no fitoterápico como único recurso enquanto ansiedade
- insônia ou sofrimento seguem se intensificando ao longo de 1 a 2 semanas
- pode valer alinhar com o médico para reavaliar o quadro de base
- Quando há abandono silencioso por sensação de ineficácia ou mal-estar subjetivo
- pode valer comunicar ao médico se isso estiver embaralhando a leitura da evolução clínica e da adesão a outros cuidados

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente apresenta rebaixamento importante do nível de consciência
- fala muito arrastada
- desorientação ou dificuldade incomum para se manter desperto.: Interromper a exploração psicoterápica
- avaliar segurança imediata e acionar suporte médico no mesmo dia
- incluindo emergência se houver risco clínico agudo
- Surge ideação suicida atual com intenção
- plano ou perda de controle
- independentemente de o paciente relacionar isso ao uso do produto.: Manejar como urgência psiquiátrica: avaliar risco

Vermelho: tratar como urgência

- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

O foco é separar efeito sedativo inespecífico, alívio situacional e uso intermitente da evolução real da ansiedade e do sono.

093 EXTRATO SECO DE VALERIANA OFFICINALIS L.

Substância: Extrato Seco de Valeriana Officinalis L..

Nomes Comerciais: Valerance, Sonotabs, Valsed, Valesstone

Uso comum

- Fitoterápico usado sobretudo em queixas de insônia leve, dificuldade para iniciar o sono e estados de tensão subjetiva. No consultório, costuma aparecer em pacientes que tentam manejar sono e ansiedade com algo percebido como “mais natural”, às vezes por conta própria e com uso irregular. Quando há benefício, ele tende a ser notado nos primeiros dias a 1 ou 2 semanas, principalmente na latência do sono e na sensação de desaceleração à noite; se o uso é intermitente, a leitura clínica fica mais confusa. O ponto central na sessão é diferenciar melhora real do descanso, sedação residual, expectativa de efeito e manutenção do padrão ansioso de base.

O paciente pode relatar

- **"Sono noturno:** Alguns pacientes descrevem adormecer com mais facilidade ou sentir o corpo menos acelerado à noite, enquanto outros não percebem mudança consistente. Na sessão, vale observar se houve melhora do descanso percebido e da continuidade do sono, ou apenas sonolência próxima ao horário de dormir sem repercussão restauradora no dia seguinte. Eventos de vida, higiene do sono instável, uso de cafeína, álcool e outros recursos para dormir podem confundir a leitura tanto quanto o uso irregular do fitoterápico.

Sedação residual: Em parte dos casos, pode surgir lentificação matinal, sensação de cabeça "pesada" ou menor vivacidade nas primeiras horas do dia. Isso pode se parecer com piora depressiva, exaustão acumulada ou privação de sono crônica, especialmente quando o paciente já chega à sessão com baixa energia basal. A discriminação depende de mapear a relação temporal entre o uso, o despertar e a recuperação ao longo do dia, sem assumir causalidade automática.

Ansiedade e tensão: Quando o paciente usa valeriana por tensão subjetiva, pode relatar menor inquietação ao fim do dia, mas nem sempre isso corresponde a redução da ansiedade ao longo das 24 horas. Na sessão, interessa notar se houve queda da reatividade corporal e da ruminação em contextos específicos ou apenas uma sensação inespecífica de amortecimento. Mudanças ambientais, melhora espontânea do quadro e expectativa positiva em relação a um produto fitoterápico podem produzir impressões semelhantes.

Adesão e automanejo: Como costuma ser percebida como opção simples e de baixo risco, a valeriana pode entrar em rotinas pouco estáveis: uso apenas em noites difíceis, interrupções sem registro claro e associação com outros recursos para dormir. Isso aparece na sessão como narrativa vaga sobre horários, frequência e contexto de uso, o que dificulta ligar mudanças do sono ao produto ou ao curso natural da semana. Também vale considerar abandono silencioso quando o paciente conclui rapidamente que "não fez nada" ou mantém o uso sem critério observável."

O que observar em sessão

- **Sono noturno:** Alguns pacientes descrevem adormecer com mais facilidade ou sentir o corpo menos acelerado à noite, enquanto outros não percebem mudança consistente. Na sessão, vale observar se houve melhora do descanso percebido e da continuidade do sono, ou apenas sonolência próxima ao horário de dormir sem repercussão restauradora no dia seguinte. Eventos de vida, higiene do sono instável, uso de cafeína, álcool e outros recursos para dormir podem confundir a leitura tanto quanto o uso irregular do fitoterápico.

Sedação residual: Em parte dos casos, pode surgir lentificação matinal, sensação de cabeça “pesada” ou menor vivacidade nas primeiras horas do dia. Isso pode se parecer com piora depressiva, exaustão acumulada ou privação de sono crônica, especialmente quando o paciente já chega à sessão com baixa energia basal. A discriminação depende de mapear a relação temporal entre o uso, o despertar e a recuperação ao longo do dia, sem assumir causalidade automática.

Ansiedade e tensão: Quando o paciente usa valeriana por tensão subjetiva, pode relatar menor inquietação ao fim do dia, mas nem sempre isso corresponde a redução da ansiedade ao longo das 24 horas. Na sessão, interessa notar se houve queda da reatividade corporal e da ruminação em contextos específicos ou apenas uma sensação inespecífica de amortecimento. Mudanças ambientais, melhora espontânea do quadro e expectativa positiva em relação a um produto fitoterápico podem produzir impressões semelhantes.

Adesão e automanejo: Como costuma ser percebida como opção simples e de baixo risco, a valeriana pode entrar em rotinas pouco estáveis: uso apenas em noites difíceis, interrupções sem registro claro e associação com outros recursos para dormir. Isso aparece na sessão como narrativa vaga sobre horários, frequência e contexto de uso, o que dificulta ligar mudanças do sono ao produto ou ao curso natural da semana. Também vale considerar abandono silencioso quando o paciente conclui rapidamente que “não fez nada” ou mantém o uso sem critério observável.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Fitoterápico usado sobretudo em queixas de insônia leve, dificuldade para iniciar o sono e estados de tensão subjetiva. No consultório, costuma aparecer em pacientes que tentam manejar sono e ansiedade com algo percebido como “mais natural”, às vezes por conta própria e com uso irregular. Quando há benefício, ele tende a ser notado nos primeiros dias a 1 ou 2 semanas, principalmente na latência do sono e na sensação de desaceleração à noite; se o uso é intermitente, a leitura clínica fica mais confusa. O ponto central na sessão é diferenciar melhora real do descanso, sedação residual, expectativa de efeito e manutenção do padrão ansioso de base.

Perguntas úteis

- "Nas noites em que você usa, o que muda de forma mais nítida: o tempo para pegar no sono, os despertares, ou só a sensação de estar mais sonolento perto da hora de deitar? , No dia seguinte, você acorda mais descansado ou apenas mais lento nas primeiras horas? , Quando sua ansiedade melhora, isso acontece ao longo do dia ou fica mais concentrado no período da noite e na hora de dormir? , Nas semanas em que o sono piorou, o que veio primeiro para você: mais tensão e pensamentos acelerados, mudanças na rotina, ou alteração no uso do produto? , Você tem usado de um jeito parecido nas diferentes noites ou acaba recorrendo só quando sente que a noite já vai ser ruim?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente mantém uso relativamente regular por 1 a 2 semanas sem qualquer melhora percebida do sono e segue com prejuízo funcional
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar a leitura clínica do quadro e do tratamento em curso
- Quando aparece sonolência matinal persistente
- lentificação ou queda de atenção que começam a interferir no trabalho
- nos estudos ou na própria sessão
- pode valer comunicar o médico para avaliar a relevância clínica desse padrão
- Quando o paciente relata uso combinado com outros recursos para dormir
- álcool ou medicações sedativas e a narrativa fica confusa quanto ao que está produzindo o efeito percebido
- pode valer alinhar com o médico para melhor discriminação do quadro
- Quando o paciente oscila entre usar
- interromper e retomar sem critério claro
- especialmente porque concluiu sozinho que “não funciona” ou porque passou a se sentir mal no dia seguinte
- pode valer comunicar o médico pela chance de adesão irregular estar confundindo a evolução clínica

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- o paciente apresenta confusão importante
- rebaixamento acentuado do nível de alerta ou mal-estar após associação referida com álcool ou outros sedativos.: Interromper o foco psicoterápico
- avaliar segurança imediata
- acionar apoio e contato médico no mesmo dia
- recorrendo à emergência se houver risco clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Emergem ideação suicida com intenção
- plano ou perda importante de controle
- independentemente de o paciente atribuir isso ao produto ou ao sofrimento de base.: Manejar como urgência psiquiátrica: avaliar risco
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- com encaminhamento à emergência quando necessário

Frase clínica

O foco é separar melhora real do sono de sedação residual, expectativa de efeito e uso irregular em um contexto de automanejo frequente.

094 HUMULUS LUPULUS L.; VALERIANA OFFICINALIS L.

Substância: Humulus Lupulus L.; Valeriana Officinalis L..

Nomes Comerciais: Remilev

Uso comum

- Associação fitoterápica com valeriana e lúpulo, usualmente encontrada em pacientes que buscam manejo de ansiedade, tensão interna e dificuldade para iniciar ou manter o sono. No consultório, tende a aparecer mais como tentativa de aliviar hiperativação noturna do que como tratamento estruturado de um transtorno psiquiátrico. Quando há benefício percebido, ele costuma ser notado nos primeiros dias a 2 semanas; nas primeiras tomadas também pode surgir sonolência, lentificação ou sensação de “ressaca” no dia seguinte. O ponto central de observação é se a melhora do sono vem acompanhada de maior regulação emocional e funcionamento diurno, ou se o paciente apenas fica mais sedado, com adesão irregular e leitura confusa do próprio quadro.

O paciente pode relatar

- **"Sono e vigília:** Alguns pacientes chegam relatando que adormecem com mais facilidade ou despertam menos durante a noite, enquanto outros descrevem sono mais pesado, dificuldade para acordar ou sensação de não ter descansado. Na sessão, isso pode aparecer como bocejos, lentificação, menor prontidão associativa ou atraso para engajar. Vale diferenciar melhora real da arquitetura subjetiva do sono de simples sedação, além de considerar higiene do sono, uso concomitante de álcool, cafeína ou outros sedativos e mudanças recentes de rotina.

Ansiedade noturna: O uso costuma surgir em contextos de ruminação ao deitar, tensão corporal e antecipação ansiosa no fim do dia. Se o paciente relata menos inquietação noturna, isso pode refletir tanto redução da ativação quanto cansaço inespecífico; por outro lado, persistência da ansiedade apesar do uso pode apontar para um quadro de base mais amplo ou para adesão intermitente. Na sessão, interessa observar se houve deslocamento do padrão ansioso para outros horários ou se a queixa ficou restrita ao momento de dormir.

Sedação diurna: Em parte dos pacientes, o que aparece não é exatamente tranquilidade, mas embotamento leve, sonolência ou menor energia no dia seguinte. Isso pode confundir a leitura clínica, sobretudo em pacientes com depressão, burnout, privação de sono crônica ou uso de outras substâncias que também reduzem alerta. O terapeuta pode notar fala mais arrastada, menor iniciativa e redução do acesso afetivo, perguntando-se se houve alívio da angústia ou apenas queda global de ativação.

Adesão e uso situacional: Como se trata de um fitoterápico frequentemente usado por conta própria ou de modo mais flexível, é comum haver tomadas apenas em noites "piores", interrupções sem registro claro e dificuldade do paciente em relacionar padrão de uso e efeito percebido. Na sessão, isso pode gerar narrativas contraditórias, como dizer que "não fez diferença" apesar de uso esporádico, ou atribuir melhora a ele em semanas com menos estresse. O ponto discriminativo é reconstruir a regularidade do uso e o contexto das noites em que o paciente recorreu ao produto."

O que observar em sessão

- **Sono e vigília:** Alguns pacientes chegam relatando que adormecem com mais facilidade ou despertam menos durante a noite, enquanto outros descrevem sono mais pesado, dificuldade para acordar ou sensação de não ter descansado. Na sessão, isso pode aparecer como bocejos, lentificação, menor prontidão associativa ou atraso para engajar. Vale diferenciar melhora real da arquitetura subjetiva do sono de simples sedação, além de considerar higiene do sono, uso concomitante de álcool, cafeína ou outros sedativos e mudanças recentes de rotina.

Ansiedade noturna: O uso costuma surgir em contextos de ruminação ao deitar, tensão corporal e antecipação ansiosa no fim do dia. Se o paciente relata menos inquietação noturna, isso pode refletir tanto redução da ativação quanto cansaço inespecífico; por outro lado, persistência da ansiedade apesar do uso pode apontar para um quadro de base mais amplo ou para adesão intermitente. Na sessão, interessa observar se houve deslocamento do padrão ansioso para outros horários ou se a queixa ficou restrita ao momento de dormir.

Sedação diurna: Em parte dos pacientes, o que aparece não é exatamente tranquilidade, mas embotamento leve, sonolência ou menor energia no dia seguinte. Isso pode confundir a leitura clínica, sobretudo em pacientes com depressão, burnout, privação de sono crônica ou uso de outras substâncias que também reduzem alerta. O terapeuta pode notar fala mais arrastada, menor iniciativa e redução do acesso afetivo, perguntando-se se houve alívio da angústia ou apenas queda global de ativação.

Adesão e uso situacional: Como se trata de um fitoterápico frequentemente usado por conta própria ou de modo mais flexível, é comum haver tomadas apenas em noites “piores”, interrupções sem registro claro e dificuldade do paciente em relacionar padrão de uso e efeito percebido. Na sessão, isso pode gerar narrativas contraditórias, como dizer que “não fez diferença” apesar de uso esporádico, ou atribuir melhora a ele em semanas com menos estresse. O ponto discriminativo é reconstruir a regularidade do uso e o contexto das noites em que o paciente recorreu ao produto.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Associação fitoterápica com valeriana e lúpulo, usualmente encontrada em pacientes que buscam manejo de ansiedade, tensão interna e dificuldade para iniciar ou manter o sono. No consultório, tende a aparecer mais como tentativa de aliviar hiperativação noturna do que como tratamento estruturado de um transtorno psiquiátrico. Quando há benefício percebido, ele costuma ser notado nos primeiros dias a 2 semanas; nas primeiras tomadas também pode surgir sonolência, lentificação ou sensação de “ressaca” no dia seguinte. O ponto central de observação é se a melhora do sono vem acompanhada de maior regulação emocional e funcionamento diurno, ou se o paciente apenas fica mais sedado, com adesão irregular e leitura confusa do próprio quadro.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que ficou mais calmo, isso veio com sensação de alívio por dentro ou mais como sono e corpo pesado? , Nas noites em que você usa, o que muda primeiro: os pensamentos desaceleram, o corpo relaxa ou você apenas apaga mais rápido? , No dia seguinte, você se sente mais descansado e funcional ou mais lento e sem energia? , Quando a noite é ruim, isso acontece mesmo usando de forma parecida, ou coincide com dias de mais estresse, conflito ou mudança de rotina? , Você percebe diferença entre as noites em que usa de modo mais regular e aquelas em que toma só quando acha que vai precisar?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve sonolência diurna persistente
- Identificação ou prejuízo funcional que começou após o início do uso
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer a contribuição do produto e de outros sedativos em uso
- Quando há uso muito irregular
- com leitura confusa de benefício ou piora
- pode valer comunicar o médico para situar a adesão real e evitar conclusões clínicas baseadas em um padrão de uso pouco consistente
- Quando o paciente mantém insônia ou ansiedade noturna sem mudança perceptível após cerca de 2 semanas de uso consistente
- pode valer alinhar com o médico assistente para reavaliar a hipótese de que o quadro de base esteja predominando
- Quando surgem sinais de abandono silencioso por desconforto no dia seguinte
- pode valer comunicar o médico assistente porque esse padrão costuma distorcer a avaliação de resposta e adesão

Vermelho: tratar como urgência

- Rebaixamento importante do nível de alerta na sessão
- dificuldade de se manter desperto
- fala muito arrastada ou desorientação
- sobretudo se houver suspeita de combinação com álcool ou outros calmantes.: Priorizar segurança imediata
- avaliar necessidade de apoio de acompanhante e acionar atendimento médico no mesmo dia
- Aparecimento ou intensificação de ideação suicida
- desesperança marcada ou sensação de perda de controle
- independentemente de o produto ser ou não o fator principal.: Fazer manejo de risco na própria sessão e acionar hoje rede de apoio
- médico assistente e emergência quando necessário

Frase clínica

O foco é distinguir melhora do sono e da ansiedade noturna de simples sedação, especialmente quando o uso é irregular e autogerido.

095 PIPER METHYSTICUM

Substância: Piper Methysticum.

Nomes Comerciais: Kava Kava Herbarium

Uso comum

- Piper methysticum (kava-kava) é um fitoterápico usado sobretudo em contextos de ansiedade, tensão e queixas de sono. No consultório, tende a aparecer mais como automedicação ou uso paralelo a outros tratamentos do que como eixo principal do cuidado. Quando há alguma mudança percebida, ela costuma ser notada nos primeiros dias a 2 semanas de uso; por outro lado, oscilações rápidas entre dias com e sem uso podem confundir a leitura clínica. O ponto central na sessão é diferenciar redução de tensão com preservação do acesso afetivo de um estado de lentificação, sonolência ou afastamento experiencial que o paciente pode interpretar como “estar melhor” apenas por estar menos reativo.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade e tensão:** Alguns pacientes descrevem diminuição da inquietação, menor tensão corporal ou sensação de estar “mais solto”, o que pode facilitar a permanência em temas difíceis na sessão. Em outros, a queda da reatividade vem acompanhada de menor nitidez emocional, fala mais lenta ou menor iniciativa associativa, o que pode ser confundido com melhora consistente do quadro. Vale comparar com a linha de base e com o contexto: alívio após evento estressor resolvido, flutuação espontânea da ansiedade e uso irregular do fitoterápico podem produzir uma impressão semelhante.

Sedação e presença: Sonolência, lentificação e redução do tônus de alerta podem aparecer como menor engajamento, pausas mais longas, dificuldade de sustentar elaboração ou aparência de cansaço na sessão. Isso pode se confundir tanto com efeito do uso quanto com privação de sono, depressão, exaustão por sobrecarga ou associação com outras substâncias sedativas. A discriminação clínica costuma depender do padrão temporal: se a presença oscila conforme o horário de uso ou varia muito entre sessões, a hipótese de efeito do produto ganha peso observacional.

Sono e ritmo: Quando o paciente usa kava-kava por tensão noturna, pode relatar adormecer com mais facilidade ou chegar à sessão menos exaurido. Ainda assim, melhora subjetiva do sono não equivale necessariamente a melhora global do quadro, e às vezes vem junto de despertar mais arrastado ou sensação de embotamento pela manhã. Mudanças recentes na rotina, álcool, cafeína, dor e outras medicações podem explicar parte importante dessas variações, especialmente quando o uso do fitoterápico é intermitente.

Adesão irregular: Por ser percebido como “natural”, o uso pode ocorrer de modo pouco estável: em dias mais difíceis, apenas à noite, em combinação com outras estratégias ou sem registro claro de frequência. Esse padrão costuma embaralhar a leitura da sessão, porque alterna dias de maior alívio com dias de retorno da tensão sem que isso represente necessariamente evolução do quadro. Também merece atenção quando o paciente minimiza o uso ou não o inclui espontaneamente entre os tratamentos em curso, o que pode ocultar uma variável relevante para entender humor, sono e nível de alerta."

O que observar em sessão

- **Ansiedade e tensão:** Alguns pacientes descrevem diminuição da inquietação, menor tensão corporal ou sensação de estar “mais solto”, o que pode facilitar a permanência em temas difíceis na sessão. Em outros, a queda da reatividade vem acompanhada de menor nitidez emocional, fala mais lenta ou menor iniciativa associativa, o que pode ser confundido com melhora consistente do quadro. Vale comparar com a linha de base e com o contexto: alívio após evento estressor resolvido, flutuação espontânea da ansiedade e uso irregular do fitoterápico podem produzir uma impressão semelhante.

Sedação e presença: Sonolência, lentificação e redução do tônus de alerta podem aparecer como menor engajamento, pausas mais longas, dificuldade de sustentar elaboração ou aparência de cansaço na sessão. Isso pode se confundir tanto com efeito do uso quanto com privação de sono, depressão, exaustão por sobrecarga ou associação com outras substâncias sedativas. A discriminação clínica costuma depender do padrão temporal: se a presença oscila conforme o horário de uso ou varia muito entre sessões, a hipótese de efeito do produto ganha peso observacional.

Sono e ritmo: Quando o paciente usa kava-kava por tensão noturna, pode relatar adormecer com mais facilidade ou chegar à sessão menos exaurido. Ainda assim, melhora subjetiva do sono não equivale necessariamente a melhora global do quadro, e às vezes vem junto de despertar mais arrastado ou sensação de embotamento pela manhã. Mudanças recentes na rotina, álcool, cafeína, dor e outras medicações podem explicar parte importante dessas variações, especialmente quando o uso do fitoterápico é intermitente.

Adesão irregular: Por ser percebido como “natural”, o uso pode ocorrer de modo pouco estável: em dias mais difíceis, apenas à noite, em combinação com outras estratégias ou sem registro claro de frequência. Esse padrão costuma embaralhar a leitura da sessão, porque alterna dias de maior alívio com dias de retorno da tensão sem que isso represente necessariamente evolução do quadro. Também merece atenção quando o paciente minimiza o uso ou não o inclui espontaneamente entre os tratamentos em curso, o que pode ocultar uma variável relevante para entender humor, sono e nível de alerta.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Piper methysticum (kava-kava) é um fitoterápico usado sobretudo em contextos de ansiedade, tensão e queixas de sono. No consultório, tende a aparecer mais como automedicação ou uso paralelo a outros tratamentos do que como eixo principal do cuidado. Quando há alguma mudança percebida, ela costuma ser notada nos primeiros dias a 2 semanas de uso; por outro lado, oscilações rápidas entre dias com e sem uso podem confundir a leitura clínica. O ponto central na sessão é diferenciar redução de tensão com preservação do acesso afetivo de um estado de lentificação, sonolência ou afastamento experiencial que o paciente pode interpretar como “estar melhor” apenas por estar menos reativo.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente melhor, isso vem como alívio com mais clareza para pensar e sentir, ou como um desligamento em que tudo fica mais distante? , Nos dias em que você usa, o que muda primeiro: a tensão no corpo, a velocidade dos pensamentos, o sono ou sua disposição para conversar? , Essa sonolência ou lentidão aparece mesmo quando você dormiu bem, ou costuma vir junto de noites ruins e cansaço acumulado? , Quando você passa um ou mais dias sem usar, o que retorna mais claramente: preocupação, agitação corporal, dificuldade para dormir ou nada muito diferente? , Você percebe se fica menos ansioso sem perder interesse e presença nas relações, ou sente que fica mais indiferente e menos implicado com as coisas?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente muito sonolento
- Identificado ou com queda importante de presença
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se há efeito do fitoterápico
- associação com outras substâncias ou outro fator clínico relevante
- Quando o uso é irregular e o paciente alterna dias de alívio e piora sem conseguir situar o que está acontecendo
- pode valer comunicar ao médico para contextualizar a leitura clínica e reduzir confusão entre efeito do produto e evolução do quadro
- Quando o paciente relata abandono silencioso do fitoterápico por desconforto
- sonolência ou sensação de estranhamento subjetivo
- pode valer informar o médico assistente porque a adesão real pode estar diferente da suposta no acompanhamento
- Quando surgem sinais de piora importante do humor
- aumento de desesperança ou ideação suicida em paralelo ao início recente ou retomada do uso
- pode valer contato com o médico para avaliação clínica compartilhada do momento

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- o paciente apresenta rebaixamento importante do nível de consciência
- confusão acentuada ou dificuldade de se manter acordado e orientado.: Interromper o trabalho interpretativo
- avaliar segurança imediata e acionar no mesmo dia suporte médico
- rede de apoio ou emergência conforme a gravidade
- Surge ideação suicida atual com intenção
- plano ou aumento rápido de urgência subjetiva
- especialmente em contexto de piora recente do humor.: Fazer manejo de risco no mesmo dia

Vermelho: tratar como urgência

- acionar psiquiatra e rede de apoio e encaminhar para avaliação de urgência quando necessário

Frase clínica

O foco é distinguir alívio da tensão de sedação e embotamento, especialmente quando o uso é intermitente e pouco integrado ao restante do tratamento.

096 VALERIANA OFFICINALIS L.

Substância: Valeriana Officinalis L..

Nomes Comerciais: Valerinati, Calmitane, Valerimed, Valyanne, Valeriane

Uso comum

- Valeriana officinalis é um fitoterápico usado sobretudo em queixas de insônia leve, tensão e inquietação, às vezes por iniciativa própria do paciente e sem o mesmo destaque dado a outros psicotrópicos. No consultório, costuma entrar mais como modulador inespecífico de sono e relaxamento do que como eixo central do tratamento. Quando há percepção de benefício, ela tende a surgir nos primeiros dias a 1 ou 2 semanas; em uso irregular, o padrão costuma oscilar bastante de uma noite para outra. O ponto principal para o terapeuta é diferenciar melhora do sono e redução de tensão de sedação residual, expectativa de melhora, mudanças de rotina e adesão intermitente.

O paciente pode relatar

- **"Sono e vigília:** Pode aparecer um início de sono mais fácil ou sensação de noite mais tranquila, mas também despertar com lentificação, sonolência matinal ou sensação de "ressaca". Na sessão, isso às vezes se traduz em fala mais lenta, menor prontidão associativa e dificuldade de sustentar elaboração logo no começo do encontro. A leitura pode se confundir com privação de sono prévia, piora depressiva, uso concomitante de álcool ou outros sedativos, além de horários muito variáveis de uso.

Ansiedade e tensão: Alguns pacientes descrevem menos inquietação corporal e menor urgência interna, enquanto outros notam pouca diferença e mantêm o mesmo padrão ansioso de base. Em sessão, vale observar se houve redução da reatividade com preservação do acesso afetivo ou se o paciente apenas chega mais amortecido e menos mobilizado. Eventos de vida, melhora espontânea após uma crise aguda e efeito de expectativa podem produzir uma impressão semelhante à de benefício do fitoterápico.

Sedação e desempenho: Quando a sedação pesa, o paciente pode relatar dificuldade para acordar, menor energia pela manhã ou queda de rendimento em tarefas que exigem atenção sustentada. No consultório, isso pode aparecer como cansaço, menor velocidade cognitiva e necessidade de mais tempo para organizar pensamento, o que pode ser confundido com humor deprimido ou exaustão por sobrecarga. Também vale considerar se o uso é ocasional, em noites específicas, porque isso costuma gerar um padrão mais irregular entre sessões.

Adesão e automanejo: Por ser percebida como "natural", a valeriana às vezes entra e sai da rotina sem que o paciente a nomeie como medicação relevante. Isso pode produzir relatos inconsistentes de efeito, com noites muito diferentes entre si e conclusões rápidas de que "funciona" ou "não funciona" sem um padrão claro. Na sessão, a discriminação depende de mapear regularidade, contexto de uso e associação com outras estratégias para dormir, sem assumir que a oscilação decorra apenas do produto."

O que observar em sessão

- **Sono e vigília:** Pode aparecer um início de sono mais fácil ou sensação de noite mais tranquila, mas também despertar com lentificação, sonolência matinal ou sensação de “ressaca”. Na sessão, isso às vezes se traduz em fala mais lenta, menor prontidão associativa e dificuldade de sustentar elaboração logo no começo do encontro. A leitura pode se confundir com privação de sono prévia, piora depressiva, uso concomitante de álcool ou outros sedativos, além de horários muito variáveis de uso.

Ansiedade e tensão: Alguns pacientes descrevem menos inquietação corporal e menor urgência interna, enquanto outros notam pouca diferença e mantêm o mesmo padrão ansioso de base. Em sessão, vale observar se houve redução da reatividade com preservação do acesso afetivo ou se o paciente apenas chega mais amortecido e menos mobilizado. Eventos de vida, melhora espontânea após uma crise aguda e efeito de expectativa podem produzir uma impressão semelhante à de benefício do fitoterápico.

Sedação e desempenho: Quando a sedação pesa, o paciente pode relatar dificuldade para acordar, menor energia pela manhã ou queda de rendimento em tarefas que exigem atenção sustentada. No consultório, isso pode aparecer como cansaço, menor velocidade cognitiva e necessidade de mais tempo para organizar pensamento, o que pode ser confundido com humor deprimido ou exaustão por sobrecarga. Também vale considerar se o uso é ocasional, em noites específicas, porque isso costuma gerar um padrão mais irregular entre sessões.

Adesão e automanejo: Por ser percebida como “natural”, a valeriana às vezes entra e sai da rotina sem que o paciente a nomeie como medicação relevante. Isso pode produzir relatos inconsistentes de efeito, com noites muito diferentes entre si e conclusões rápidas de que “funciona” ou “não funciona” sem um padrão claro. Na sessão, a discriminação depende de mapear regularidade, contexto de uso e associação com outras estratégias para dormir, sem assumir que a oscilação decorra apenas do produto.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Valeriana officinalis é um fitoterápico usado sobretudo em queixas de insônia leve, tensão e inquietação, às vezes por iniciativa própria do paciente e sem o mesmo destaque dado a outros psicotrópicos. No consultório, costuma entrar mais como modulador inespecífico de sono e relaxamento do que como eixo central do tratamento. Quando há percepção de benefício, ela tende a surgir nos primeiros dias a 1 ou 2 semanas; em uso irregular, o padrão costuma oscilar bastante de uma noite para outra. O ponto principal para o terapeuta é diferenciar melhora do sono e redução de tensão de sedação residual, expectativa de melhora, mudanças de rotina e adesão intermitente.

Perguntas úteis

- "Quando você percebeu alguma mudança, ela apareceu mais como sono realmente melhor na noite seguinte ou como mais lentidão e sonolência no dia seguinte? , Nos dias em que você usa, o que muda de forma mais nítida: a tensão no corpo, os pensamentos acelerados ou apenas o horário em que consegue deitar e dormir? , Quando a noite é melhor, isso acontece mesmo em dias de rotina parecida, ou coincide mais com dias menos estressantes e com menos estímulo antes de dormir? , Você nota um padrão estável quando usa de modo parecido, ou o efeito parece depender muito do horário, do contexto e de outras coisas que você tomou naquela noite? , Essa sensação de estar mais calmo vem com preservação da sua clareza e do seu acesso emocional, ou você se sente mais amortecido e menos presente?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente à sessão com sonolência importante
- lentificação ou prejuízo funcional pela manhã
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se há relação com o uso e com outras substâncias associadas
- Quando o uso é muito irregular e o paciente alterna benefício percebido
- ausência de efeito e abandono silencioso
- pode valer comunicar ao médico para situar a adesão real no acompanhamento
- Quando surgem piora de humor
- irritabilidade incomum ou aumento de desesperança após o início ou retomada do uso
- pode valer alinhar com o médico para avaliação clínica
- sobretudo se houver outros fatores concomitantes
- Quando o paciente combina valeriana com álcool
- outros indutores do sono ou ansiolíticos e passa a relatar sedação excessiva ou lapsos de funcionamento
- pode valer comunicar ao médico pela relevância clínica dessa associação

Vermelho: tratar como urgência

- Rebaixamento importante do nível de consciência
- confusão acentuada ou dificuldade de contato durante a sessão
- especialmente se houver suspeita de combinação com álcool ou outros sedativos.: Interromper o trabalho clínico usual
- acionar apoio imediato e buscar avaliação médica no mesmo dia
- Aparecimento de ideação suicida com intenção
- plano ou perda de controle
- independentemente de a valeriana parecer ou não relacionada ao quadro.: Fazer manejo de risco imediatamente

Vermelho: tratar como urgência

- acionar rede de apoio e encaminhar para avaliação de urgência conforme necessidade

Frase clínica

O foco é separar melhora real do sono e da tensão de sedação residual, expectativa de melhora e uso irregular pouco nomeado pelo paciente.

097 ALPRAZOLAM

Substância: Alprazolam.

Nomes Comerciais: Alprazolam, Tranquinal Slg, Tranquinal, Apraz, Frontal

Uso comum

- Alprazolam é um benzodiazepínico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade aguda, crises de pânico, insônia associada à ansiedade e uso prolongado já incorporado à rotina. Na terapia, o ponto central não é apenas se houve alívio, mas como o uso reorganiza a experiência subjetiva: redução rápida da tensão em horas, possível sonolência ou lentificação logo após o uso, e, com uso contínuo por semanas ou meses, risco de oscilações entre alívio, sedação, esquecimento e necessidade percebida de tomar para funcionar. Mudanças abruptas no padrão de uso podem se parecer com piora do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade aguda:** Em parte dos pacientes, a sessão mostra queda nítida da tensão, menos urgência interna e menor reatividade somática, o que pode facilitar a fala ou, ao contrário, achatar a elaboração. Isso pode ser lido como melhora consistente do quadro, mas vale comparar com a linha de base fora das horas próximas ao uso e com a presença de estressores recentes. Quando o alívio aparece de modo muito dependente de momentos específicos do dia ou de situações temidas, a leitura clínica muda: pode haver mais manejo pontual da ansiedade do que mudança mais ampla do funcionamento.

Sedação e ritmo: Sonolência, fala mais lenta, menor vivacidade associativa e redução do tônus emocional podem aparecer na sessão, sobretudo quando o paciente usou a medicação pouco antes do atendimento. Esse padrão pode se confundir com retraimento depressivo, exaustão por privação de sono ou efeito de outras substâncias, inclusive álcool. Observar o ritmo da sessão em comparação com encontros anteriores e perguntar pelo horário do uso ajuda a discriminar lentificação medicamentosa de piora do humor.

Memória e elaboração: Alguns pacientes ficam mais soltos para falar, mas com menor retenção do que foi trabalhado, mais dificuldade de encadear eventos ou de acessar nuances afetivas. Isso pode parecer resistência, dissociação leve ou baixa motivação para o processo, quando às vezes o que predomina é uma sessão menos integrável subjetivamente. Se o paciente relata que melhora na hora, mas depois lembra pouco da conversa ou das próprias decisões, vale registrar esse padrão e diferenciá-lo de evitamento defensivo habitual.

Uso condicionado: Com o tempo, pode surgir a ideia de que só consegue sair, dormir, trabalhar ou enfrentar conflito se tiver tomado a medicação. Na sessão, isso aparece como estreitamento do repertório de enfrentamento e menor confiança em recursos próprios, mas também pode refletir fase de crise real ou ambiente de vida muito sobrecarregado. A distinção clínica passa por observar se houve perda progressiva de autonomia em tarefas antes toleráveis e se o uso ficou ligado a contextos previsíveis ou se se expandiu para quase qualquer desconforto.

Adesão e oscilação: Esquecimentos, uso em horários variáveis, tomadas extras em dias difíceis ou interrupções por conta própria podem produzir um vai-e-vem clínico que se parece com instabilidade emocional. O paciente pode chegar em uma sessão mais sedado e em outra mais tenso, irritável ou insone, sem que isso corresponda necessariamente a mudança estrutural do quadro. Quando a narrativa fica fragmentada ou contraditória, vale explorar o padrão concreto de uso recente antes de concluir recaída, resistência ou agravamento.

Descontinuação: Redução brusca ou interrupção pode ser seguida por aumento de ansiedade, insônia, inquietação, tremor, irritabilidade e sensação de estar piorando muito. Na terapia, isso facilmente se confunde com retorno integral do transtorno de base, especialmente se ocorreu após um período de aparente estabilidade. A pista clínica costuma estar na relação temporal entre mudança no uso e piora rápida, sobretudo quando o paciente descreve que o mal-estar veio em poucos dias e com intensidade desproporcional ao contexto."

O que observar em sessão

- **Ansiedade aguda:** Em parte dos pacientes, a sessão mostra queda nítida da tensão, menos urgência interna e menor reatividade somática, o que pode facilitar a fala ou, ao contrário, achatar a elaboração. Isso pode ser lido como melhora consistente do quadro, mas vale comparar com a linha de base fora das horas próximas ao uso e com a presença de estressores recentes. Quando o alívio aparece de modo muito dependente de momentos específicos do dia ou de situações temidas, a leitura clínica muda: pode haver mais manejo pontual da ansiedade do que mudança mais ampla do funcionamento.

Sedação e ritmo: Sonolência, fala mais lenta, menor vivacidade associativa e redução do tônus emocional podem aparecer na sessão, sobretudo quando o paciente usou a medicação pouco antes do atendimento. Esse padrão pode se confundir com retraimento depressivo, exaustão por privação de sono ou efeito de outras substâncias, inclusive álcool. Observar o ritmo da sessão em comparação com encontros anteriores e perguntar pelo horário do uso ajuda a discriminar lentificação medicamentosa de piora do humor.

Memória e elaboração: Alguns pacientes ficam mais soltos para falar, mas com menor retenção do que foi trabalhado, mais dificuldade de encadear eventos ou de acessar nuances afetivas. Isso pode parecer resistência, dissociação leve ou baixa motivação para o processo, quando às vezes o que predomina é uma sessão menos integrável subjetivamente. Se o paciente relata que melhora na hora, mas depois lembra pouco da conversa ou das próprias decisões, vale registrar esse padrão e diferenciá-lo de evitamento defensivo habitual.

Uso condicionado: Com o tempo, pode surgir a ideia de que só consegue sair, dormir, trabalhar ou enfrentar conflito se tiver tomado a medicação. Na sessão, isso aparece como estreitamento do repertório de enfrentamento e menor confiança em recursos próprios, mas também pode refletir fase de crise real ou ambiente de vida muito sobrecarregado. A distinção clínica passa por observar se houve perda progressiva de autonomia em tarefas antes toleráveis e se o uso ficou ligado a contextos previsíveis ou se se expandiu para quase qualquer desconforto.

Adesão e oscilação: Esquecimentos, uso em horários variáveis, tomadas extras em dias difíceis ou interrupções por conta própria podem produzir um vai-e-vem clínico que se parece com instabilidade emocional. O paciente pode chegar em uma sessão mais sedado e em outra mais tenso, irritável ou insone, sem que isso corresponda necessariamente a mudança estrutural do quadro. Quando a narrativa fica fragmentada ou contraditória, vale explorar o padrão concreto de uso recente antes de concluir recaída, resistência ou agravamento.

Descontinuação: Redução brusca ou interrupção pode ser seguida por aumento de ansiedade, insônia, inquietação, tremor, irritabilidade e sensação de estar piorando muito. Na terapia, isso facilmente se confunde com retorno integral do transtorno de base, especialmente se ocorreu após um período de aparente estabilidade. A pista clínica costuma estar na relação temporal entre mudança no uso e piora rápida, sobretudo quando o paciente descreve que o mal-estar veio em poucos dias e com intensidade desproporcional ao contexto.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Alprazolam é um benzodiazepínico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade aguda, crises de pânico, insônia associada à ansiedade e uso prolongado já incorporado à rotina. Na terapia, o ponto central não é apenas se houve alívio, mas como o uso reorganiza a experiência subjetiva: redução rápida da tensão em horas, possível sonolência ou lentificação logo após o uso, e, com uso contínuo por semanas ou meses, risco de oscilações entre alívio, sedação, esquecimento e necessidade percebida de tomar para funcionar. Mudanças abruptas no padrão de uso podem se parecer com piora do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente melhor, essa melhora dura ao longo do dia ou fica mais concentrada nas horas depois que toma a medicação? , Nas sessões em que você chega mais lento ou sonolento, isso se parece com tristeza e desânimo ou mais com corpo pesado e cabeça menos nítida? , Quando a ansiedade aumenta, isso vem ligado a situações específicas da sua vida ou aparece principalmente quando o efeito parece estar passando ou quando você muda o padrão de uso? , Você tem percebido que consegue enfrentar algumas situações por recursos seus, ou sente que só dá conta se tiver tomado a medicação antes? , Depois das nossas conversas, você costuma lembrar e usar o que foi trabalhado, ou sente que na hora ajuda mas depois fica tudo mais apagado? , Quando houve piora recente, ela começou junto de alguma mudança no jeito de tomar, ou aconteceu mesmo mantendo o padrão de uso igual ao de antes?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar necessidade de usar para atividades cada vez mais amplas do cotidiano
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar possível estreitamento do repertório de enfrentamento e dependência subjetiva do uso
- Quando a sessão mostra sedação recorrente
- lentificação importante ou prejuízo de memória que interfere no trabalho terapêutico ou na rotina
- pode valer comunicar o médico para avaliação da tolerabilidade clínica
- Quando surgem oscilações marcadas entre sonolência
- ansiedade intensa e insônia em paralelo a esquecimentos
- tomadas extras ou interrupções
- pode valer contato com o médico para esclarecer se o padrão de uso está confundindo a leitura do quadro
- Quando o paciente interrompeu por conta própria e em poucos dias ficou muito mais ansioso
- irritadiço ou sem dormir
- pode valer alinhar com o médico para diferenciar descontinuação de recaída do transtorno de base
- Quando há uso combinado com álcool ou outros depressores do sistema nervoso central referido em sessão

Amarelo: alinhar em breve

- especialmente com rebaixamento importante do estado de alerta
- pode valer comunicação ao médico pela relevância clínica do padrão

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente chega muito rebaixado
- confuso
- com fala bastante pastosa
- dificuldade de se manter desperto ou refere uso associado a álcool e não consegue se organizar com segurança.: Agir no mesmo dia
- avaliar condições imediatas de segurança
- acionar rede de apoio e buscar contato médico ou serviço de urgência quando necessário
- Após interrupção ou redução abrupta
- o paciente aparece com agitação intensa
- tremor importante
- sudorese
- confusão ou piora rápida que foge do padrão habitual dele.: Tratar como situação de urgência clínica
- contatar o médico no mesmo dia e encaminhar para avaliação emergencial se houver instabilidade importante

Frase clínica

O foco clínico é distinguir alívio rápido da ansiedade de sedação, uso condicionado e piora associada a mudanças irregulares no padrão de uso.

098 BROMAZEPAM

Substância: Bromazepam.

Nomes Comerciais: Bromazepam, Lexma, Fluxtar, Somalium, Lexotan

Uso comum

- Bromazepam é um benzodiazepínico ansiolítico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade, insônia associada à tensão psíquica e momentos de crise. No consultório, o mais útil é acompanhar o que muda nas primeiras horas e nos primeiros dias após início ou retomada, quando sedação, lentificação, alívio rápido da tensão ou sensação de “desligamento” podem alterar o padrão da sessão. Em uso contínuo por semanas a meses, vale observar acomodação subjetiva, uso mais automático, oscilação entre dias com e sem tomada e piora rebote de ansiedade quando há interrupções ou esquecimentos. O foco clínico é distinguir alívio da ansiedade de embotamento, sedação e adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Alguns pacientes chegam mais lentos, sonolentos, com fala menos espontânea, menor iniciativa associativa e redução da reatividade emocional. Isso pode ser lido apressadamente como melhora da ansiedade ou, em outro extremo, como agravamento depressivo. A discriminação depende de comparar com a linha de base, com o horário em que o paciente costuma tomar a medicação e com a presença de outros fatores sedativos, como privação de sono, álcool ou outras medicações.

Ansiedade aguda: Pode haver alívio relativamente rápido da tensão corporal, da urgência interna e da sensação de estar “no limite”, o que às vezes melhora a capacidade de permanecer na sessão. Em parte dos casos, porém, a redução da ansiedade vem acompanhada de menor acesso afetivo e menor elaboração, produzindo uma sessão aparentemente mais estável, mas menos trabalhável. Também convém diferenciar esse efeito de uma melhora ligada a resolução de estressores recentes ou, ao contrário, de ansiedade que retorna entre tomadas e é confundida com piora global do quadro.

Cognição e memória: Esquecimentos, dificuldade de recuperar o fio da conversa, menor atenção sustentada e sensação de cabeça “anuviada” podem aparecer e interferir no trabalho psicoterápico. Na sessão, isso pode se manifestar como perda de detalhes importantes, repetição de temas ou dificuldade de acompanhar intervenções mais complexas. O quadro pode se confundir com ansiedade intensa, exaustão, uso de substâncias ou sintomas depressivos, por isso vale observar se há relação temporal consistente com os dias e horários de uso.

Uso automático: Com o passar das semanas, alguns pacientes deixam de perceber nuances do efeito e passam a descrever apenas que “precisam” da medicação para funcionar ou dormir. Na sessão, isso pode surgir como pouca curiosidade sobre variações do próprio estado, dificuldade de nomear o que mudou e tendência a atribuir qualquer oscilação à falta ou presença do comprimido. Esse padrão pode refletir tanto benefício estável quanto dependência psicológica do ritual de uso, além de esconder adesão irregular ou aumento do sofrimento de base.

Descontinuação irregular: Quando há esquecimentos, interrupções por conta própria ou uso apenas em dias considerados piores, podem surgir ansiedade de rebote, irritabilidade, insônia, inquietação e sensação de desorganização subjetiva. Em sessão, isso às vezes parece recaída abrupta do quadro, especialmente se o paciente não menciona espontaneamente mudanças no uso. A pista clínica costuma estar na oscilação rápida entre sessões ou dentro da mesma semana, sem correspondência clara com eventos de vida.

Álcool e desinibição: Em alguns casos, o paciente relata uso concomitante com álcool ou chega com maior desinibição, julgamento mais frouxo e menor monitoramento do que diz ou faz. Isso pode ser confundido com melhora da inibição social ou com maior confiança no vínculo terapêutico. Vale considerar se a mudança é situacional, ligada ao contexto da sessão, ou se acompanha sinais de lentificação, sonolência e lapsos de memória."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Alguns pacientes chegam mais lentos, sonolentos, com fala menos espontânea, menor iniciativa associativa e redução da reatividade emocional. Isso pode ser lido apressadamente como melhora da ansiedade ou, em outro extremo, como agravamento depressivo. A discriminação depende de comparar com a linha de base, com o horário em que o paciente costuma tomar a medicação e com a presença de outros fatores sedativos, como privação de sono, álcool ou outras medicações.

Ansiedade aguda: Pode haver alívio relativamente rápido da tensão corporal, da urgência interna e da sensação de estar “no limite”, o que às vezes melhora a capacidade de permanecer na sessão. Em parte dos casos, porém, a redução da ansiedade vem acompanhada de menor acesso afetivo e menor elaboração, produzindo uma sessão aparentemente mais estável, mas menos trabalhável. Também convém diferenciar esse efeito de uma melhora ligada a resolução de estressores recentes ou, ao contrário, de ansiedade que retorna entre tomadas e é confundida com piora global do quadro.

Cognição e memória: Esquecimentos, dificuldade de recuperar o fio da conversa, menor atenção sustentada e sensação de cabeça “anuviada” podem aparecer e interferir no trabalho psicoterápico. Na sessão, isso pode se manifestar como perda de detalhes importantes, repetição de temas ou dificuldade de acompanhar intervenções mais complexas. O quadro pode se confundir com ansiedade intensa, exaustão, uso de substâncias ou sintomas depressivos, por isso vale observar se há relação temporal consistente com os dias e horários de uso.

Uso automático: Com o passar das semanas, alguns pacientes deixam de perceber nuances do efeito e passam a descrever apenas que “precisam” da medicação para funcionar ou dormir. Na sessão, isso pode surgir como pouca curiosidade sobre variações do próprio estado, dificuldade de nomear o que mudou e tendência a atribuir qualquer oscilação à falta ou presença do comprimido. Esse padrão pode refletir tanto benefício estável quanto dependência psicológica do ritual de uso, além de esconder adesão irregular ou aumento do sofrimento de base.

Descontinuação irregular: Quando há esquecimentos, interrupções por conta própria ou uso apenas em dias considerados piores, podem surgir ansiedade de rebote, irritabilidade, insônia, inquietação e sensação de desorganização subjetiva. Em sessão, isso às vezes parece recaída abrupta do quadro, especialmente se o paciente não menciona espontaneamente mudanças no uso. A pista clínica costuma estar na oscilação rápida entre sessões ou dentro da mesma semana, sem correspondência clara com eventos de vida.

Álcool e desinibição: Em alguns casos, o paciente relata uso concomitante com álcool ou chega com maior desinibição, julgamento mais frouxo e menor monitoramento do que diz ou faz. Isso pode ser confundido com melhora da inibição social ou com maior confiança no vínculo terapêutico. Vale considerar se a mudança é situacional, ligada ao contexto da sessão, ou se acompanha sinais de lentificação, sonolência e lapsos de memória.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Bromazepam é um benzodiazepínico ansiolítico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade, insônia associada à tensão psíquica e momentos de crise. No consultório, o mais útil é acompanhar o que muda nas primeiras horas e nos primeiros dias após início ou retomada, quando sedação, lentificação, alívio rápido da tensão ou sensação de “desligamento” podem alterar o padrão da sessão. Em uso contínuo por semanas a meses, vale observar acomodação subjetiva, uso mais automático, oscilação entre dias com e sem tomada e piora rebote de ansiedade quando há interrupções ou esquecimentos. O foco clínico é distinguir alívio da ansiedade de embotamento, sedação e adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais calmo, isso vem com mais clareza para pensar e falar ou com uma sensação de ficar meio desligado da conversa e das emoções? , Nos dias em que a ansiedade piora de repente, aconteceu algo no ambiente ou isso aparece mais como uma oscilação sem motivo claro, especialmente em dias em que você tomou diferente do habitual? , Quando você chega mais lento ou sonolento, isso parece cansaço do seu estado emocional, noite ruim de sono, uso de álcool, ou você nota uma relação mais direta com o remédio? , Esse alívio que você percebe ajuda você a enfrentar situações que antes evitava, ou ele funciona mais como um apagamento temporário da tensão sem mudar seu modo de lidar com elas? , Quando você esquece, atrasa ou decide não tomar, o que muda nas horas seguintes e no dia seguinte: volta um padrão conhecido seu ou aparece algo mais abrupto e diferente do habitual? , Você tem notado falhas de memória ou dificuldade de acompanhar a conversa em momentos específicos do dia, ou isso está mais espalhado e parecido com quando sua ansiedade já estava alta antes?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- lentificado ou com prejuízo claro de atenção e memória
- pode valer alinhar com o médico assistente para avaliar impacto funcional e segurança do uso
- Quando surgem esquecimentos frequentes
- interrupções por conta própria ou uso muito irregular
- pode valer comunicar o médico assistente porque a oscilação clínica pode estar sendo confundida com piora do quadro de base
- Quando o paciente relata uso concomitante com álcool ou outras substâncias sedativas
- pode valer alinhar com o médico assistente pelo aumento de risco de rebaixamento
- desinibição e lapsos de memória
- Quando a ansiedade retorna de forma abrupta entre tomadas ou após dias sem uso
- pode valer comunicar o médico assistente para discriminar rebote
- adesão irregular e evolução do transtorno
- Quando o paciente descreve necessidade crescente de recorrer ao medicamento para qualquer tensão cotidiana e isso começa a organizar a rotina psíquica

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico assistente pela mudança do padrão de uso e pelo impacto no tratamento

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente aparece muito confuso
- dificilmente se mantém desperto
- perde o fio de modo acentuado ou apresenta rebaixamento importante do nível de consciência.: Priorizar segurança
- acionar apoio imediato e buscar avaliação médica no mesmo dia; considerar emergência conforme o grau de rebaixamento
- Surge ideação suicida com plano ou perda importante de controle associada a intoxicação aparente
- uso combinado de substâncias ou desinibição marcada.: Fazer manejo de crise
- acionar rede de apoio e avaliação médica imediata
- incluindo emergência quando necessário

Frase clínica

O ponto central é diferenciar alívio da ansiedade de sedação, embotamento e oscilação ligada a uso irregular.

099 CLOBAZAM

Substância: Clobazam.

Nomes Comerciais: Urbanil, Frisium

Uso comum

- Clobazam é um benzodiazepínico usado em alguns quadros de ansiedade, agitação e, em certos pacientes, como adjuvante em epilepsia. No consultório, costuma aparecer mais pelo impacto sobre nível de alerta, ritmo da sessão, memória recente e padrão de uso do que por mudanças elaborativas mais finas. Os efeitos percebidos tendem a surgir já nos primeiros dias; com o passar das semanas, vale observar acomodação parcial da sedação em alguns casos, manutenção do embotamento em outros e risco de uso irregular com oscilação entre alívio, sonolência e piora rebote de ansiedade ou insônia. O ponto central é diferenciar contenção ansiosa útil de lentificação que empobrece presença psíquica, além de rastrear dependência do efeito imediato e interrupções não combinadas.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** A sessão pode ganhar um tom mais lento, com fala arrastada, bocejos, menor iniciativa associativa e dificuldade de sustentar atenção. Isso pode ser lido apressadamente como melhora da ansiedade ou como retraimento depressivo, quando às vezes se trata de redução do nível de alerta. Também convém considerar privação de sono, uso de álcool, outras medicações sedativas e horário em que o paciente tomou a medicação antes da sessão.

Ansiedade rebote: Alguns pacientes chegam descrevendo alívio claro em parte do dia e piora mais intensa da ansiedade quando o efeito parece passar ou quando pulam tomadas. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação incomum entre contenção e urgência, o que pode ser confundido com instabilidade do quadro de base ou reação a eventos da semana. A discriminação depende de mapear a relação temporal entre piora, horários de uso e dias de esquecimento, sem assumir causalidade automática.

Cognição e memória: Pode haver dificuldade para recuperar detalhes recentes, acompanhar encadeamentos mais longos ou lembrar combinados da própria terapia. Em alguns casos isso se mistura com ansiedade alta, dissociação leve, sobrecarga de vida ou déficit atencional prévio, o que pede comparação com a linha de base anterior ao início do uso. Quando a perda de nitidez cognitiva coincide com maior sonolência ou uso irregular, a hipótese medicamentosa ganha mais peso observacional.

Vínculo e acesso afetivo: O paciente pode parecer mais contido, menos reativo e até mais disponível para permanecer na sessão, mas com menor acesso a nuances afetivas e menor capacidade de elaboração. Isso pode ser vivido pelo terapeuta como sessão mais fácil, embora às vezes haja empobrecimento do trabalho psíquico e não propriamente melhora clínica global. Também vale diferenciar esse achatamento de um momento de defesa, exaustão emocional ou alívio legítimo após redução de ansiedade intensa.

Uso irregular: Clobazam pode entrar rapidamente em um padrão de uso mais instrumental, em que o paciente passa a associá-lo a dormir, enfrentar situações específicas ou conter crises. Na sessão, isso aparece como tomada variável, esquecimentos, antecipação ansiosa de ficar sem o efeito ou abandono silencioso por sonolência e lentificação. Sem explorar esse padrão, o terapeuta pode interpretar como recaída espontânea aquilo que talvez esteja ligado a adesão irregular ou interrupções por conta própria.

Descontinuação: Quando o uso é interrompido abruptamente ou fica errático, podem surgir em poucos dias piora de ansiedade, insônia, irritabilidade, tremor subjetivo e sensação de desorganização. Esse quadro pode se parecer com retorno do problema original, sobretudo se o paciente omite que reduziu ou parou por conta própria. O ponto clínico é notar mudança relativamente brusca no padrão da sessão após período de maior contenção ou sedação."

O que observar em sessão

- **Sedação:** A sessão pode ganhar um tom mais lento, com fala arrastada, bocejos, menor iniciativa associativa e dificuldade de sustentar atenção. Isso pode ser lido apressadamente como melhora da ansiedade ou como retraimento depressivo, quando às vezes se trata de redução do nível de alerta. Também convém considerar privação de sono, uso de álcool, outras medicações sedativas e horário em que o paciente tomou a medicação antes da sessão.

Ansiedade rebote: Alguns pacientes chegam descrevendo alívio claro em parte do dia e piora mais intensa da ansiedade quando o efeito parece passar ou quando pulam tomadas. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação incomum entre contenção e urgência, o que pode ser confundido com instabilidade do quadro de base ou reação a eventos da semana. A discriminação depende de mapear a relação temporal entre piora, horários de uso e dias de esquecimento, sem assumir causalidade automática.

Cognição e memória: Pode haver dificuldade para recuperar detalhes recentes, acompanhar encadeamentos mais longos ou lembrar combinados da própria terapia. Em alguns casos isso se mistura com ansiedade alta, dissociação leve, sobrecarga de vida ou déficit atencional prévio, o que pede comparação com a linha de base anterior ao início do uso. Quando a perda de nitidez cognitiva coincide com maior sonolência ou uso irregular, a hipótese medicamentosa ganha mais peso observacional.

Vínculo e acesso afetivo: O paciente pode parecer mais contido, menos reativo e até mais disponível para permanecer na sessão, mas com menor acesso a nuances afetivas e menor capacidade de elaboração. Isso pode ser vivido pelo terapeuta como sessão mais fácil, embora às vezes haja empobrecimento do trabalho psíquico e não propriamente melhora clínica global. Também vale diferenciar esse achatamento de um momento de defesa, exaustão emocional ou alívio legítimo após redução de ansiedade intensa.

Uso irregular: Clobazam pode entrar rapidamente em um padrão de uso mais instrumental, em que o paciente passa a associá-lo a dormir, enfrentar situações específicas ou conter crises. Na sessão, isso aparece como tomada variável, esquecimentos, antecipação ansiosa de ficar sem o efeito ou abandono silencioso por sonolência e lentificação. Sem explorar esse padrão, o terapeuta pode interpretar como recaída espontânea aquilo que talvez esteja ligado a adesão irregular ou interrupções por conta própria.

Descontinuação: Quando o uso é interrompido abruptamente ou fica errático, podem surgir em poucos dias piora de ansiedade, insônia, irritabilidade, tremor subjetivo e sensação de desorganização. Esse quadro pode se parecer com retorno do problema original, sobretudo se o paciente omite que reduziu ou parou por conta própria. O ponto clínico é notar mudança relativamente brusca no padrão da sessão após período de maior contenção ou sedação.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Clobazam é um benzodiazepínico usado em alguns quadros de ansiedade, agitação e, em certos pacientes, como adjuvante em epilepsia. No consultório, costuma aparecer mais pelo impacto sobre nível de alerta, ritmo da sessão, memória recente e padrão de uso do que por mudanças elaborativas mais finas. Os efeitos percebidos tendem a surgir já nos primeiros dias; com o passar das semanas, vale observar acomodação parcial da sedação em alguns casos, manutenção do embotamento em outros e risco de uso irregular com oscilação entre alívio, sonolência e piora rebote de ansiedade ou insônia. O ponto central é diferenciar contenção ansiosa útil de lentificação que empobrece presença psíquica, além de rastrear dependência do efeito imediato e interrupções não combinadas.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais calmo, isso vem junto com sensação de estar mais presente na sessão ou mais desligado e lento? , Nos dias em que a ansiedade piora, isso costuma acontecer de modo espalhado pela semana ou mais em horários específicos e em dias em que você esqueceu ou mudou o uso? , Essa dificuldade de lembrar e organizar o pensamento já fazia parte do seu padrão ou ficou mais perceptível depois que começou a medicação? , Quando você parece menos afetado pelas situações, isso tem cara de alívio com mais liberdade interna ou de um certo achatamento, como se tudo tocasse menos do que antes? , Nas últimas semanas, houve dias em que você deixou de tomar, tomou em horários muito diferentes ou evitou usar por causa de sono, lentidão ou outro incômodo? , Quando o sono piora ou você fica mais agitado, isso veio junto de alguma mudança no uso da medicação ou parece independente disso?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- chegar muito sonolento ou relata lentificação que compromete trabalho
- direção ou cuidado cotidiano
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar impacto funcional e tolerabilidade
- Quando surgem esquecimentos frequentes
- uso em horários muito variáveis ou interrupções por conta própria
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer o padrão de adesão e evitar leituras equivocadas de recaída
- Quando a ansiedade ou a insônia pioram de forma mais brusca após redução
- esquecimento repetido ou parada não combinada
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar descontinuação de evolução do quadro
- Quando o paciente descreve necessidade crescente de recorrer ao medicamento para enfrentar situações cada vez mais amplas do cotidiano
- pode valer alinhar com o médico assistente para contextualizar dependência psicológica do efeito imediato
- Quando há embotamento

Amarelo: alinhar em breve

- prejuízo de memória ou sedação persistente que empobrecem o trabalho terapêutico por semanas
- pode valer alinhar com o médico assistente para compartilhar observações de sessão relevantes ao acompanhamento

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente relata parada abrupta recente e chega muito agitado
- trêmulo
- confuso ou com piora intensa do estado geral.: Acionar o médico assistente no mesmo dia e
- se houver risco clínico importante ou rápida deterioração
- encaminhar para avaliação de urgência
- Há rebaixamento importante do nível de consciência
- dificuldade marcante para se manter acordado ou combinação de sedação intensa com uso de álcool ou outras substâncias.: Interromper a condução usual da sessão
- avaliar segurança imediata e acionar rede de apoio e atendimento de urgência quando necessário

Frase clínica

O foco é distinguir alívio ansioso de sedação e rastrear uso irregular, rebote e empobrecimento cognitivo que alteram o trabalho terapêutico.

100 CLORIDRATO DE BUSPIRONA

Substância: Cloridrato de Buspirona.

Nomes Comerciais: Ansitec, Stima, Tague

Uso comum

- A buspirona é um ansiolítico não benzodiazepínico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade generalizada e quadros de tensão persistente, às vezes após dificuldade com sedação ou dependência subjetiva de outros ansiolíticos. Na clínica, não tende a produzir alívio imediato; quando há benefício, ele costuma se tornar mais nítido ao longo de 2 a 4 semanas, por vezes um pouco depois. Nas primeiras semanas, o ponto central é distinguir oscilação ansiosa do próprio quadro, expectativa de melhora rápida, adesão irregular e desconfortos iniciais que podem levar a abandono silencioso.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade basal:** Em parte dos pacientes, a sessão começa a mostrar redução gradual da apreensão difusa, da ruminação e da tensão corporal, mais do que uma mudança brusca de humor. Quando o paciente espera um efeito imediato, pode concluir cedo demais que “não fez nada”, e isso se confunde facilmente com ansiedade ainda ativa, frustração com o tratamento ou uso irregular. Vale comparar com a linha de base de algumas semanas, e não apenas com dias isolados mais difíceis.

Ativação inicial: No início, podem surgir inquietação, sensação de estar mais acelerado por dentro, leve piora subjetiva da ansiedade ou irritabilidade, o que na sessão pode se parecer com recrudescimento do quadro. A discriminação clínica passa por observar se houve mudança temporal próxima ao início do uso e se a experiência é mais corporal e nova do que o padrão ansioso habitual do paciente. Também convém considerar cafeína, privação de sono, estressores recentes e outras medicações como possíveis confundidores.

Tontura e mal-estar: Alguns pacientes descrevem tontura, cabeça leve, náusea ou desconforto inespecífico, sobretudo no começo, e isso pode aparecer na sessão como menor presença, necessidade de sentar-se de outro modo ou dificuldade de sustentar atenção. Esses sinais podem ser lidos apressadamente como ansiedade somática, dissociação leve ou desorganização emocional, quando às vezes o componente físico está em primeiro plano. Se o incômodo se torna relevante, é comum aumentar o risco de adesão irregular sem que o paciente comunique espontaneamente.

Sono e sedação: Diferentemente de ansiolíticos mais sedativos, a buspirona nem sempre produz sensação de “desligar”, e alguns pacientes estranham justamente a ausência desse efeito. Na sessão, isso pode aparecer como decepção com um tratamento que ajuda parcialmente a ansiedade, mas não oferece alívio rápido para insônia ou hiperalerta noturno. Quando há sonolência ou piora do sono, vale não atribuir de imediato ao medicamento, porque o próprio quadro ansioso, hábitos de sono e uso concomitante de outras substâncias podem explicar melhor o padrão.

Adesão e expectativa: Como o benefício tende a ser gradual e pouco dramático, a adesão pode oscilar sem grande alarde: esquecimentos, uso intermitente ou abandono por concluir que “não mudou nada”. O terapeuta pode notar narrativas inconsistentes sobre melhora, piora em dias alternados e dificuldade do paciente em ligar sua experiência ao padrão de uso real. Nesses casos, a tarefa clínica é menos interpretar resistência e mais mapear com precisão a sequência entre início, expectativas, efeitos percebidos e continuidade do uso."

O que observar em sessão

- **Ansiedade basal:** Em parte dos pacientes, a sessão começa a mostrar redução gradual da apreensão difusa, da ruminação e da tensão corporal, mais do que uma mudança brusca de humor. Quando o paciente espera um efeito imediato, pode concluir cedo demais que “não fez nada”, e isso se confunde facilmente com ansiedade ainda ativa, frustração com o tratamento ou uso irregular. Vale comparar com a linha de base de algumas semanas, e não apenas com dias isolados mais difíceis.

Ativação inicial: No início, podem surgir inquietação, sensação de estar mais acelerado por dentro, leve piora subjetiva da ansiedade ou irritabilidade, o que na sessão pode se parecer com recrudescimento do quadro. A discriminação clínica passa por observar se houve mudança temporal próxima ao início do uso e se a experiência é mais corporal e nova do que o padrão ansioso habitual do paciente. Também convém considerar cafeína, privação de sono, estressores recentes e outras medicações como possíveis confundidores.

Tontura e mal-estar: Alguns pacientes descrevem tontura, cabeça leve, náusea ou desconforto inespecífico, sobretudo no começo, e isso pode aparecer na sessão como menor presença, necessidade de sentar-se de outro modo ou dificuldade de sustentar atenção. Esses sinais podem ser lidos apressadamente como ansiedade somática, dissociação leve ou desorganização emocional, quando às vezes o componente físico está em primeiro plano. Se o incômodo se torna relevante, é comum aumentar o risco de adesão irregular sem que o paciente comunique espontaneamente.

Sono e sedação: Diferentemente de ansiolíticos mais sedativos, a buspirona nem sempre produz sensação de “desligar”, e alguns pacientes estranham justamente a ausência desse efeito. Na sessão, isso pode aparecer como decepção com um tratamento que ajuda parcialmente a ansiedade, mas não oferece alívio rápido para insônia ou hiperalerta noturno. Quando há sonolência ou piora do sono, vale não atribuir de imediato ao medicamento, porque o próprio quadro ansioso, hábitos de sono e uso concomitante de outras substâncias podem explicar melhor o padrão.

Adesão e expectativa: Como o benefício tende a ser gradual e pouco dramático, a adesão pode oscilar sem grande alarde: esquecimentos, uso intermitente ou abandono por concluir que “não mudou nada”. O terapeuta pode notar narrativas inconsistentes sobre melhora, piora em dias alternados e dificuldade do paciente em ligar sua experiência ao padrão de uso real. Nesses casos, a tarefa clínica é menos interpretar resistência e mais mapear com precisão a sequência entre início, expectativas, efeitos percebidos e continuidade do uso.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A buspirona é um ansiolítico não benzodiazepínico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade generalizada e quadros de tensão persistente, às vezes após dificuldade com sedação ou dependência subjetiva de outros ansiolíticos. Na clínica, não tende a produzir alívio imediato; quando há benefício, ele costuma se tornar mais nítido ao longo de 2 a 4 semanas, por vezes um pouco depois. Nas primeiras semanas, o ponto central é distinguir oscilação ansiosa do próprio quadro, expectativa de melhora rápida, adesão irregular e desconfortos iniciais que podem levar a abandono silencioso.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que a ansiedade está igual, isso significa que continua com a mesma intensidade o dia todo ou que os picos diminuíram, mas a tensão de fundo permanece? , Essa sensação de inquietação que apareceu é parecida com a sua ansiedade de costume ou tem um caráter mais novo, mais corporal, como se fosse difícil ficar parado mesmo sem um pensamento específico? , Nos dias em que você sente que o remédio não ajuda, houve uso regular nas últimas semanas ou esse julgamento vem de dias mais soltos e irregulares? , O que mais te incomoda neste momento: continuar preocupado como antes, sentir desconfortos físicos novos, ou frustrar-se por não perceber uma mudança rápida? , Quando o sono piora, isso vem junto de mais preocupação e ruminação à noite ou parece acontecer mesmo em noites em que a cabeça está relativamente mais calma?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente relata uso irregular
- abandono silencioso ou forte ambivalência por não perceber melhora nas primeiras semanas
- pode valer alinhar com o médico assistente para evitar leitura equivocada de ineficácia
- Quando surgem tontura
- náusea ou mal-estar que começam a interferir na presença em sessão
- na rotina ou na continuidade do tratamento
- pode valer comunicar o médico para reavaliar tolerabilidade
- Quando a ansiedade parece piorar de forma sustentada após o início
- especialmente com inquietação nova e irritabilidade que não combinam com a linha de base
- pode valer contato com o médico para discriminar efeito inicial de evolução do quadro
- Quando
- após algumas semanas de uso aparentemente regular
- não se observa qualquer mudança clínica perceptível e o paciente segue muito sintomático
- pode valer alinhar com o médico para atualização da leitura do caso

Vermelho: tratar como urgência

- Surge ideação suicida nova ou claramente intensificada
- sobretudo nas primeiras semanas
- com piora de agitação
- desesperança ou impulsividade.: Fazer avaliação de risco na hora e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente chega muito confuso
- intensamente agitado

Vermelho: tratar como urgência

- com tremores marcados
- sudorese importante ou aparência de adoecimento agudo fora do seu padrão habitual.: Interromper o foco usual da sessão e encaminhar para avaliação médica imediata
- acionando suporte de urgência se necessário

Frase clínica

O foco é acompanhar mudança gradual da ansiedade e separar ineficácia real de expectativa de alívio imediato, desconforto inicial e adesão irregular.

101 DIAZEPAM

Substância: Diazepam.

Nomes Comerciais: Diazepam, Santiazepam, Compaz, Uni-Diazepax, Valium, Relapax, Furp-Diazepam, Diazepam Nq

Uso comum

- Diazepam é um benzodiazepínico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade intensa, insônia, crises agudas de tensão e, por vezes, uso prolongado já incorporado à rotina. Na sessão, o mais útil é acompanhar o contraste entre alívio rápido de ansiedade e possíveis custos subjetivos como lentificação, sonolência, menor acesso afetivo e oscilação de presença psíquica. Esses efeitos podem surgir logo no início ou após retomadas irregulares; em uso contínuo por semanas a meses, vale observar acomodação, dependência do recurso para enfrentar situações e dificuldade quando há esquecimentos ou interrupções. O foco clínico é diferenciar contenção útil, sedação excessiva, adesão irregular e piora do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Alguns pacientes chegam mais lentos, sonolentos, com fala menos espontânea, menor iniciativa associativa e dificuldade de sustentar elaboração mais fina. Isso pode ser lido apressadamente como retraimento depressivo, desinvestimento no processo ou resistência, quando às vezes acompanha o uso recente, aumento de frequência de uso ou combinação com outras substâncias sedativas. Também vale lembrar que noites mal dormidas, exaustão e sobrecarga de vida podem produzir apresentação semelhante; a diferença costuma aparecer na variação entre sessões e na proximidade temporal com o uso.

Ansiedade de base: O diazepam pode reduzir a intensidade aguda da ansiedade e da tensão corporal, o que às vezes melhora a capacidade de permanecer na sessão sem transbordamento. Em parte dos casos, porém, o paciente passa a relatar menos ansiedade enquanto mantém esquivas, hipervigilância interpessoal e dependência de alívio rápido diante de qualquer desconforto. Isso pode confundir melhora sintomática parcial com elaboração mais consistente do conflito ou, ao contrário, mascarar agravamentos quando o medicamento é usado de forma intermitente em momentos críticos.

Cognição e presença: Pode haver lapsos de memória recente, menor nitidez para reconstruir acontecimentos, dificuldade de concentração e sensação de estar meio desligado. Na clínica, isso interfere na continuidade do trabalho, na recordação de temas importantes e na percepção de si ao longo da semana. Convém não atribuir automaticamente esses sinais ao medicamento: ansiedade elevada, privação de sono, uso de álcool, depressão e estresse também podem reduzir atenção e memória, e a comparação com a baseline ajuda a discriminar.

Adesão e uso situacional: Com diazepam, a adesão nem sempre segue um padrão estável: alguns pacientes usam apenas em dias mais difíceis, outros aumentam por conta própria em fases de maior tensão, e há quem minimize o quanto depende do recurso para dormir, sair de casa ou enfrentar conflitos. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação marcada de funcionamento entre encontros, inconsistência no relato e dificuldade de nomear o papel do medicamento na rotina. Eventos de vida agudos podem explicar parte dessas variações, mas o padrão de uso costuma ser decisivo para entender o que é efeito do remédio, o que é ansiedade de base e o que é tentativa de autorregulação.

Descontinuação: Quando há esquecimento, redução abrupta ou interrupção após uso contínuo, podem surgir aumento importante de ansiedade, insônia, irritabilidade, tremor, sensação de inquietação e maior sensibilidade corporal, às vezes em horas a poucos dias. Na sessão, isso pode parecer recaída súbita do quadro original ou reação a estressores recentes, especialmente se o paciente não menciona espontaneamente mudanças no uso. O ponto clínico é notar a mudança temporal brusca e perguntar pelo padrão dos últimos dias antes de concluir que se trata apenas de piora psicológica.

Vínculo e evitação: Em alguns casos, o alívio rápido favorece presença mínima suficiente para o trabalho; em outros, o medicamento entra como solução predominante para qualquer aumento de afeto, reduzindo tolerância à exploração emocional. O terapeuta pode notar sessões mais planas, menor contato com ambivalência e busca de contenção imediata sempre que o tema se intensifica. Isso não deve ser lido automaticamente como defesa caracterológica fixa, porque

pode variar conforme horário de uso, contexto de crise e expectativa do paciente de não suportar o desconforto sem um amortecedor químico."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Alguns pacientes chegam mais lentos, sonolentos, com fala menos espontânea, menor iniciativa associativa e dificuldade de sustentar elaboração mais fina. Isso pode ser lido apressadamente como retraimento depressivo, desinvestimento no processo ou resistência, quando às vezes acompanha o uso recente, aumento de frequência de uso ou combinação com outras substâncias sedativas. Também vale lembrar que noites mal dormidas, exaustão e sobrecarga de vida podem produzir apresentação semelhante; a diferença costuma aparecer na variação entre sessões e na proximidade temporal com o uso.

Ansiedade de base: O diazepam pode reduzir a intensidade aguda da ansiedade e da tensão corporal, o que às vezes melhora a capacidade de permanecer na sessão sem transbordamento. Em parte dos casos, porém, o paciente passa a relatar menos ansiedade enquanto mantém esquivas, hipervigilância interpessoal e dependência de alívio rápido diante de qualquer desconforto. Isso pode confundir melhora sintomática parcial com elaboração mais consistente do conflito ou, ao contrário, mascarar agravamentos quando o medicamento é usado de forma intermitente em momentos críticos.

Cognição e presença: Pode haver lapsos de memória recente, menor nitidez para reconstruir acontecimentos, dificuldade de concentração e sensação de estar "meio desligado". Na clínica, isso interfere na continuidade do trabalho, na recordação de temas importantes e na percepção de si ao longo da semana. Convém não atribuir automaticamente esses sinais ao medicamento: ansiedade elevada, privação de sono, uso de álcool, depressão e estresse também podem reduzir atenção e memória, e a comparação com a baseline ajuda a discriminar.

Adesão e uso situacional: Com diazepam, a adesão nem sempre segue um padrão estável: alguns pacientes usam apenas em dias mais difíceis, outros aumentam por conta própria em fases de maior tensão, e há quem minimize o quanto depende do recurso para dormir, sair de casa ou enfrentar conflitos. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação marcada de funcionamento entre encontros, inconsistência no relato e dificuldade de nomear o papel do medicamento na rotina. Eventos de vida agudos podem explicar parte dessas variações, mas o padrão de uso costuma ser decisivo para entender o que é efeito do remédio, o que é ansiedade de base e o que é tentativa de autorregulação.

Descontinuação: Quando há esquecimento, redução abrupta ou interrupção após uso contínuo, podem surgir aumento importante de ansiedade, insônia, irritabilidade, tremor, sensação de inquietação e maior sensibilidade corporal, às vezes em horas a poucos dias. Na sessão, isso pode parecer recaída súbita do quadro original ou reação a estressores recentes, especialmente se o paciente não menciona espontaneamente mudanças no uso. O ponto clínico é notar a mudança temporal brusca e perguntar pelo padrão dos últimos dias antes de concluir que se trata apenas de piora psicológica.

Vínculo e evitação: Em alguns casos, o alívio rápido favorece presença mínima suficiente para o trabalho; em outros, o medicamento entra como solução predominante para qualquer aumento de afeto, reduzindo tolerância à exploração emocional. O terapeuta pode notar sessões mais "planas", menor contato com ambivalência e busca de contenção imediata sempre que o tema se intensifica. Isso não deve ser lido automaticamente como defesa caracterológica fixa, porque

pode variar conforme horário de uso, contexto de crise e expectativa do paciente de não suportar o desconforto sem um amortecedor químico.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Diazepam é um benzodiazepínico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade intensa, insônia, crises agudas de tensão e, por vezes, uso prolongado já incorporado à rotina. Na sessão, o mais útil é acompanhar o contraste entre alívio rápido de ansiedade e possíveis custos subjetivos como lentificação, sonolência, menor acesso afetivo e oscilação de presença psíquica. Esses efeitos podem surgir logo no início ou após retomadas irregulares; em uso contínuo por semanas a meses, vale observar acomodação, dependência do recurso para enfrentar situações e dificuldade quando há esquecimentos ou interrupções. O foco clínico é diferenciar contenção útil, sedação excessiva, adesão irregular e piora do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso costuma acontecer em dias de maior cansaço emocional ou mais perto dos momentos em que usa o remédio? , Nessas últimas semanas, a redução da ansiedade veio junto com mais liberdade para fazer o que evitava ou você se sente apenas mais contido por dentro? , Quando sua ansiedade piora de repente, isso parece ligado a algum acontecimento, a noites ruins de sono ou a dias em que o uso ficou diferente do habitual? , Esses lapsos de memória e dificuldade de concentração aparecem mesmo quando você está menos ansioso, ou surgem principalmente nos momentos de maior tensão? , Quando você fica sem usar ou esquece, o que muda primeiro: o sono, a tensão no corpo, a irritação ou a sensação de medo? , Você percebe que recorre ao remédio para atravessar situações específicas, como dormir, sair, trabalhar ou conversar sobre algo difícil?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente muito sonolento
- lentificado ou com prejuízo claro de atenção e memória na sessão
- pode valer alinhar com o médico assistente para avaliar impacto funcional e segurança do uso
- Quando aparece uso cada vez mais frequente para lidar com situações cotidianas
- com dificuldade de passar um dia sem recorrer ao medicamento
- pode valer comunicar o médico pela possibilidade de dependência do recurso e perda de discriminação do padrão de ansiedade
- Quando há piora abrupta de ansiedade
- insônia
- irritabilidade ou tremor após esquecimentos
- interrupção ou uso muito irregular
- pode valer alinhar com o médico para diferenciar descontinuação de recaída do quadro de base
- Quando o paciente combina o medicamento com álcool ou outras substâncias sedativas e isso repercute na sessão com rebaixamento importante de alerta

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer contato com o médico pelo aumento de risco clínico
- Quando o tratamento psicoterápico fica repetidamente empobrecido por embotamento
- pouca presença psíquica ou dificuldade de recordar conteúdos relevantes
- pode valer comunicar o médico para contextualizar o impacto observado no processo

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente apresenta sonolência intensa
- fala muito arrastada
- confusão evidente ou dificuldade de se manter desperto
- especialmente se houve uso junto com álcool ou outras substâncias.: Interromper a exploração clínica
- avaliar segurança imediata
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia; considerar emergência se houver rebaixamento importante de consciência
- Após interrupção ou redução abrupta referida pelo paciente
- surgem agitação intensa
- tremor marcado
- confusão
- piora rápida do estado geral ou relato de convulsão.: Tratar como situação de urgência
- orientar busca de avaliação médica imediata e acionar rede de apoio e emergência quando necessário

Frase clínica

Com diazepam, o centro da observação é separar alívio útil de ansiedade, sedação excessiva, uso dependente do recurso e descontinuação.

102 EXTRATO SECO DE PASSIFLORA

Substância: Extrato Seco de Passiflora.

Nomes Comerciais: Fiquezen

Uso comum

- Fitoterápico usado sobretudo em contextos de ansiedade leve, tensão, inquietação e dificuldade para dormir. No consultório, tende a aparecer mais como tentativa de manejo de sintomas do que como eixo central do tratamento, e o efeito percebido, quando ocorre, costuma ser notado nos primeiros dias a 1 ou 2 semanas. O ponto principal de observação é se houve redução discreta da ativação com preservação de presença psíquica e funcionalidade, ou se o paciente passou a chegar mais sonolento, menos nítido ou com uso irregular conforme a intensidade dos sintomas. Como costuma circular sem o mesmo enquadre de “medicação psiquiátrica”, vale atenção especial à adesão intermitente e à leitura imprecisa do que mudou de fato.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade e tensão:** Alguns pacientes descrevem menor aceleração interna, menos sensação de estar "ligado" e mais facilidade para desacelerar no fim do dia. Em sessão, isso pode aparecer como fala menos pressionada, menor urgência e mais tolerância ao silêncio, mas também pode coincidir com melhora por resolução de estressores, férias, redução de cafeína ou simples flutuação do quadro. Quando o uso é irregular, a impressão subjetiva tende a oscilar com o contexto, o que pode confundir efeito do fitoterápico com alívio situacional.

Sono e ritmo: A mudança mais perceptível às vezes aparece no adormecer ou na qualidade subjetiva do sono, com repercussão no humor e na disponibilidade psíquica da sessão seguinte. Se o paciente chega mais lento, bocejando ou com dificuldade de organizar o pensamento, vale considerar tanto efeito sedativo quanto privação de sono prévia, rotina desorganizada, uso concomitante de álcool ou outros agentes calmantes. A discriminação clínica depende menos do rótulo do produto e mais do padrão temporal entre uso, noite de sono e funcionamento no dia seguinte.

Sedação e presença: Parte dos pacientes pode parecer mais contida ou sonolenta, o que às vezes é vivido como alívio e outras vezes como perda de nitidez. Na sessão, isso pode ser confundido com retraimento depressivo, desinvestimento no processo terapêutico ou defesa evitativa diante de temas mobilizadores. Vale observar se há redução da ansiedade com manutenção de acesso afetivo e elaboração, ou se a pessoa fica apenas menos reativa e menos disponível mentalmente.

Adesão intermitente: Por ser um fitoterápico e frequentemente percebido como recurso "leve", o uso pode ocorrer apenas em dias mais difíceis, em horários variáveis ou sem registro claro de continuidade. Esse padrão costuma produzir narrativas pouco consistentes sobre benefício ou incômodo, dificultando separar resposta clínica de expectativa, efeito de contexto e flutuação espontânea dos sintomas. Em terapia, o mais útil é mapear regularidade, motivo do uso em cada ocasião e o que o paciente nota nas horas seguintes."

O que observar em sessão

- **Ansiedade e tensão:** Alguns pacientes descrevem menor aceleração interna, menos sensação de estar “ligado” e mais facilidade para desacelerar no fim do dia. Em sessão, isso pode aparecer como fala menos pressionada, menor urgência e mais tolerância ao silêncio, mas também pode coincidir com melhora por resolução de estressores, férias, redução de cafeína ou simples flutuação do quadro. Quando o uso é irregular, a impressão subjetiva tende a oscilar com o contexto, o que pode confundir efeito do fitoterápico com alívio situacional.

Sono e ritmo: A mudança mais perceptível às vezes aparece no adormecer ou na qualidade subjetiva do sono, com repercussão no humor e na disponibilidade psíquica da sessão seguinte. Se o paciente chega mais lento, bocejando ou com dificuldade de organizar o pensamento, vale considerar tanto efeito sedativo quanto privação de sono prévia, rotina desorganizada, uso concomitante de álcool ou outros agentes calmantes. A discriminação clínica depende menos do rótulo do produto e mais do padrão temporal entre uso, noite de sono e funcionamento no dia seguinte.

Sedação e presença: Parte dos pacientes pode parecer mais contida ou sonolenta, o que às vezes é vivido como alívio e outras vezes como perda de nitidez. Na sessão, isso pode ser confundido com retraimento depressivo, desinvestimento no processo terapêutico ou defesa evitativa diante de temas mobilizadores. Vale observar se há redução da ansiedade com manutenção de acesso afetivo e elaboração, ou se a pessoa fica apenas menos reativa e menos disponível mentalmente.

Adesão intermitente: Por ser um fitoterápico e frequentemente percebido como recurso “leve”, o uso pode ocorrer apenas em dias mais difíceis, em horários variáveis ou sem registro claro de continuidade. Esse padrão costuma produzir narrativas pouco consistentes sobre benefício ou incômodo, dificultando separar resposta clínica de expectativa, efeito de contexto e flutuação espontânea dos sintomas. Em terapia, o mais útil é mapear regularidade, motivo do uso em cada ocasião e o que o paciente nota nas horas seguintes.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Fitoterápico usado sobretudo em contextos de ansiedade leve, tensão, inquietação e dificuldade para dormir. No consultório, tende a aparecer mais como tentativa de manejo de sintomas do que como eixo central do tratamento, e o efeito percebido, quando ocorre, costuma ser notado nos primeiros dias a 1 ou 2 semanas. O ponto principal de observação é se houve redução discreta da ativação com preservação de presença psíquica e funcionalidade, ou se o paciente passou a chegar mais sonolento, menos nítido ou com uso irregular conforme a intensidade dos sintomas. Como costuma circular sem o mesmo enquadre de “medicação psiquiátrica”, vale atenção especial à adesão intermitente e à leitura imprecisa do que mudou de fato.

Perguntas úteis

- "Quando você sente que ele ajudou, o que mudou primeiro: a tensão no corpo, a velocidade dos pensamentos ou a facilidade para dormir? , Nos dias em que você usa, você fica mais calmo e presente ou mais apagado e com menos clareza para pensar? , Essa melhora aparece mesmo em dias estressantes, ou só quando a semana já estava mais leve por outros motivos? , Quando você chega mais sonolento ou mais lento, isso costuma vir depois do uso, de uma noite mal dormida ou de algum outro hábito que mudou naquele dia? , Você tem usado de forma parecida ao longo da semana ou mais como um recurso pontual quando os sintomas apertam?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- Identificado ou com prejuízo funcional associado ao uso
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer a contribuição do fitoterápico e de outros agentes sedativos em paralelo
- Quando há uso muito irregular e o paciente atribui mudanças importantes de humor
- ansiedade ou sono ao produto sem um padrão temporal minimamente consistente
- pode valer comunicação para qualificar a leitura clínica e evitar conclusões apressadas
- Quando o paciente relata associação frequente com álcool ou outros recursos para "potencializar" o efeito calmante
- pode valer alinhar com o médico assistente pelo risco de piora de sedação e leitura confusa do quadro
- Quando surgem piora relevante de ansiedade
- insônia persistente ou manutenção do sofrimento apesar de 1 a 2 semanas de uso percebido como regular
- pode valer comunicar para reavaliar se o quadro de base está evoluindo além do que o paciente vinha tentando manejar sozinho

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- o paciente apresenta rebaixamento importante de consciência
- dificuldade marcante para se manter desperto ou fala muito arrastada após uso associado a álcool ou outros calmantes.: Interromper a exploração psicoterápica
- avaliar segurança imediata
- acionar rede de apoio e buscar avaliação médica no mesmo dia conforme a gravidade
- Há ideação suicida emergente ou intensificada
- especialmente se acompanhada de piora aguda de ansiedade
- desesperança ou desorganização do sono.: Fazer manejo de risco na própria sessão e acionar psiquiatra

Vermelho: tratar como urgência

- rede de apoio e emergência quando necessário
- sem atribuir automaticamente o quadro ao fitoterápico

Frase clínica

O foco é distinguir alívio discreto da ativação de sedação inespecífica, sempre considerando uso intermitente e mudanças de contexto.

103 LORAZEPAM

Substância: Lorazepam.

Nomes Comerciais: Lorazepam, Lorazepam (Port.344/98, Lista B1), Lorax

Uso comum

- Lorazepam é um benzodiazepínico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade aguda, insônia associada à ativação psíquica, crises de pânico ou períodos de desorganização emocional em que se buscou alívio rápido. Na terapia, o mais útil é acompanhar o que muda nas primeiras horas e nos primeiros dias de uso - redução de tensão, sonolência, lentificação, menor reatividade - e, ao longo de semanas, observar se o paciente passa a depender do efeito para dormir, sair de casa ou tolerar afetos. Também vale atenção a uso irregular, tomadas “de resgate” fora de um padrão claro e piora entre doses, que podem se confundir com recaída do quadro de base ou com estressores recentes.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter menos agitação visível, fala mais lenta, maior latência de resposta e menor acesso associativo. Isso pode ser vivido como alívio legítimo, mas também como embotamento situacional, cansaço ou dificuldade de sustentar elaboração. A leitura clínica se confunde facilmente com privação de sono, depressão, uso de álcool ou outras medicações sedativas, então vale comparar com a linha de base e com o horário em que o paciente costuma usar a medicação.

Ansiedade aguda: Pode haver queda rápida da tensão corporal, da urgência interna e da sensação de estar à beira de perder o controle, o que às vezes melhora a capacidade de permanecer na sessão. Em outros casos, a ansiedade de fundo segue presente, apenas menos expressa no corpo ou na fala, e isso pode dar uma impressão de melhora maior do que a efetivamente consolidada. Eventos de vida, evitação de situações ansiogênicas e uso apenas em momentos críticos podem produzir oscilações que parecem resposta estável quando ainda não há um novo baseline.

Cognição e memória: Alguns pacientes ficam mais dispersos, com dificuldade de recuperar detalhes, acompanhar encadeamentos ou reter o que foi trabalhado na sessão. No consultório, isso pode aparecer como repetição de temas, menor precisão temporal e dificuldade de transformar insight em continuidade entre encontros. Esse padrão também pode decorrer de ansiedade intensa, noites mal dormidas, sobrecarga emocional ou uso concomitante de outras substâncias, por isso a discriminação depende de situar quando a dificuldade aparece e se ela varia conforme o uso.

Adesão e uso situacional: Lorazepam frequentemente entra na rotina de modo menos estável do que o paciente inicialmente descreve: uso "só quando precisa", antecipação antes de situações temidas, esquecimento em alguns dias e retomada em momentos de maior tensão. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação importante entre encontros ou dentro da mesma semana, sem correspondência clara com eventos externos. Quando o padrão de uso fica opaco, o terapeuta corre o risco de atribuir tudo ao curso do quadro psíquico e perder um fator relevante de leitura clínica.

Dependência do efeito: Com o tempo, alguns pacientes passam a organizar sono, deslocamentos, vida social ou exposição emocional em torno da possibilidade de tomar a medicação. Isso pode reduzir sofrimento no curto prazo, mas também estreitar repertório de enfrentamento e aumentar medo de ficar sem o recurso. Na sessão, convém diferenciar entre melhora funcional sustentada e funcionamento condicionado à presença do efeito, especialmente quando o paciente evita experiências que antes vinha conseguindo elaborar.

Interdose e retirada: Quando há uso frequente ou irregular, podem surgir piora de ansiedade, insônia, irritabilidade, tremor fino ou sensação de descompensação entre tomadas ou após interrupção por conta própria. No consultório, isso pode ser lido como recaída abrupta, crise desencadeada por evento de vida ou "prova" de que o quadro piorou, quando o timing sugere relação com mudança no padrão de uso. A pista clínica costuma estar na temporalidade: piora rápida após reduzir, esquecer ou ficar sem a medicação, com alívio após retomar."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter menos agitação visível, fala mais lenta, maior latência de resposta e menor acesso associativo. Isso pode ser vivido como alívio legítimo, mas também como embotamento situacional, cansaço ou dificuldade de sustentar elaboração. A leitura clínica se confunde facilmente com privação de sono, depressão, uso de álcool ou outras medicações sedativas, então vale comparar com a linha de base e com o horário em que o paciente costuma usar a medicação.

Ansiedade aguda: Pode haver queda rápida da tensão corporal, da urgência interna e da sensação de estar à beira de perder o controle, o que às vezes melhora a capacidade de permanecer na sessão. Em outros casos, a ansiedade de fundo segue presente, apenas menos expressa no corpo ou na fala, e isso pode dar uma impressão de melhora maior do que a efetivamente consolidada. Eventos de vida, evitação de situações ansiogênicas e uso apenas em momentos críticos podem produzir oscilações que parecem resposta estável quando ainda não há um novo baseline.

Cognição e memória: Alguns pacientes ficam mais dispersos, com dificuldade de recuperar detalhes, acompanhar encadeamentos ou reter o que foi trabalhado na sessão. No consultório, isso pode aparecer como repetição de temas, menor precisão temporal e dificuldade de transformar insight em continuidade entre encontros. Esse padrão também pode decorrer de ansiedade intensa, noites mal dormidas, sobrecarga emocional ou uso concomitante de outras substâncias, por isso a discriminação depende de situar quando a dificuldade aparece e se ela varia conforme o uso.

Adesão e uso situacional: Lorazepam frequentemente entra na rotina de modo menos estável do que o paciente inicialmente descreve: uso “só quando precisa”, antecipação antes de situações temidas, esquecimento em alguns dias e retomada em momentos de maior tensão. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação importante entre encontros ou dentro da mesma semana, sem correspondência clara com eventos externos. Quando o padrão de uso fica opaco, o terapeuta corre o risco de atribuir tudo ao curso do quadro psíquico e perder um fator relevante de leitura clínica.

Dependência do efeito: Com o tempo, alguns pacientes passam a organizar sono, deslocamentos, vida social ou exposição emocional em torno da possibilidade de tomar a medicação. Isso pode reduzir sofrimento no curto prazo, mas também estreitar repertório de enfrentamento e aumentar medo de ficar sem o recurso. Na sessão, convém diferenciar entre melhora funcional sustentada e funcionamento condicionado à presença do efeito, especialmente quando o paciente evita experiências que antes vinha conseguindo elaborar.

Interdose e retirada: Quando há uso frequente ou irregular, podem surgir piora de ansiedade, insônia, irritabilidade, tremor fino ou sensação de descompensação entre tomadas ou após interrupção por conta própria. No consultório, isso pode ser lido como recaída abrupta, crise desencadeada por evento de vida ou “prova” de que o quadro piorou, quando o timing sugere relação com mudança no padrão de uso. A pista clínica costuma estar na temporalidade: piora rápida após reduzir, esquecer ou ficar sem a medicação, com alívio após retomar.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Lorazepam é um benzodiazepínico que costuma aparecer em pacientes com ansiedade aguda, insônia associada à ativação psíquica, crises de pânico ou períodos de desorganização emocional em que se buscou alívio rápido. Na terapia, o mais útil é acompanhar o que muda nas primeiras horas e nos primeiros dias de uso - redução de tensão, sonolência, lentificação, menor reatividade - e, ao longo de semanas, observar se o paciente passa a depender do efeito para dormir, sair de casa ou tolerar afetos. Também vale atenção a uso irregular, tomadas “de resgate” fora de um padrão claro e piora entre doses, que podem se confundir com recaída do quadro de base ou com estressores recentes.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais calmo, isso vem junto com mais clareza para pensar e agir ou com uma sensação de ficar meio amortecido e menos presente? , Nos dias em que a ansiedade piora, isso costuma acontecer depois de algum gatilho identificável ou em períodos em que você atrasou, esqueceu ou mudou seu padrão de uso? , Quando você usa a medicação antes de sair, dormir ou enfrentar algo difícil, o que exatamente melhora: o medo diminui, o corpo desacelera ou você sente que só consegue ir se tiver tomado? , Essa dificuldade de memória ou de concentração aparece o dia todo ou fica mais marcada em certos horários, especialmente perto de quando você usa a medicação? , Quando você passa algum tempo sem usar, o que aparece primeiro: volta de preocupações antigas do seu jeito habitual ou uma piora mais brusca, com irritação, tremor, insônia ou sensação de desorganização? , Você percebe diferença entre estar menos ansioso e estar menos afetado por tudo, inclusive por coisas que antes mobilizavam você?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a organizar atividades básicas
- sono ou saídas em torno da necessidade de tomar lorazepam
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar dependência funcional do efeito e impacto no tratamento
- Quando surgem sonolência importante
- lentificação ou falhas de memória que começam a comprometer trabalho
- direção
- cuidado com filhos ou continuidade da psicoterapia
- pode valer comunicar o médico assistente para revisão clínica
- Quando a ansiedade piora de forma abrupta após esquecimento
- redução por conta própria ou períodos sem a medicação
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar descontinuação de agravamento do quadro de base
- Quando o paciente relata uso cada vez mais frequente em situações antes toleráveis
- pode valer comunicar o médico para contextualizar possível escalada de uso e estreitamento do repertório de enfrentamento

Amarelo: alinhar em breve

- Quando há pouca resposta clínica após algumas semanas
- apesar de uso aparentemente regular
- pode valer contato com o médico assistente para compartilhar a persistência de sofrimento e a linha de base observada em sessão

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente chega muito sonolento
- confuso
- cambaleante ou com fala bastante prejudicada
- especialmente se houve uso de álcool
- opioides ou outros sedativos.: Priorizar segurança imediata
- evitar que saia desacompanhado se houver risco
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia; considerar emergência se houver rebaixamento importante
- Após interrupção abrupta ou período sem a medicação
- aparecem agitação intensa
- tremores marcados
- confusão ou sinais de desorganização que fogem muito da linha de base.: Tratar como situação de urgência clínica
- contatar o psiquiatra no mesmo dia e acionar emergência se o estado mental ou a segurança estiverem comprometidos

Frase clínica

O foco clínico com lorazepam é distinguir alívio da ansiedade de sedação, dependência funcional do efeito e piora ligada a uso irregular.

104 EXTRATO SECO DE HYPERICUM PERFORATUM L

Substância: Extrato Seco de Hypericum Perforatum L.

Nomes Comerciais: Hipericin, Hipérico Herbarium

Uso comum

- Fitoterápico usado sobretudo em quadros depressivos leves a moderados e, às vezes, por iniciativa própria do paciente antes de procurar tratamento psiquiátrico. No consultório, o ponto central costuma ser menos a resposta antidepressiva em si e mais a leitura do que mudou desde o início do uso: alguma melhora pode ser percebida ao longo de 2 a 6 semanas, enquanto interrupções, trocas de marca ou uso irregular podem embaralhar a linha de base. Como muitos pacientes o entendem como “natural”, vale observar adesão pouco consistente, automanejo silencioso e combinações com outros tratamentos sem que isso apareça espontaneamente na sessão.

O paciente pode relatar

- **"Humor e baseline:** Pode surgir uma melhora parcial do humor, com menos choro, mais disposição para tarefas e algum alívio da desesperança, mas sem recuperação mais ampla da iniciativa, do prazer ou da capacidade de elaboração. Na sessão, isso às vezes aparece como um paciente menos sofrido e ao mesmo tempo ainda empobrecido afetivamente ou pouco engajado. A leitura pode se confundir com remissão espontânea, efeito de eventos de vida favoráveis ou oscilação natural de quadros leves, especialmente quando o início do uso não ficou bem datado.

Ativação e ansiedade: Em parte dos pacientes, o começo do uso pode coincidir com mais inquietação, irritabilidade, aceleração subjetiva ou pior tolerância a estímulos, o que na sessão pode parecer aumento de ansiedade habitual. Vale diferenciar se houve mudança qualitativa recente no ritmo da fala, na impaciência e na capacidade de permanecer em temas difíceis, em vez de apenas intensificação de um traço já conhecido. Também entram como confundidores cafeína, privação de sono, estressores recentes e outras substâncias usadas em paralelo.

Sono: O padrão de sono pode mudar nas primeiras semanas, com dificuldade para iniciar o sono, sono mais leve ou, em alguns casos, melhora secundária à redução do sofrimento depressivo. Em sessão, o terapeuta pode notar mais fadiga, menor tolerância à frustração ou oscilação de atenção, mas isso nem sempre aponta para piora do quadro de base. Quando o sono se altera perto do início, da interrupção ou de retomadas irregulares, a cronologia ajuda mais do que a intensidade isolada do sintoma.

Adesão e automanejo: Como se trata de um fitoterápico, não é raro que o paciente o use com lógica de experimento pessoal, suspenda quando se sente melhor, retome em momentos de piora ou alterne marcas sem considerar isso clinicamente relevante. Na sessão, esse padrão pode aparecer como narrativa fragmentada, dificuldade de datar mudanças e atribuições globais do tipo “acho que não fez diferença”. Isso pode ser confundido com ausência de resposta, quando na verdade a exposição foi irregular demais para permitir leitura clínica consistente.

Combinações silenciosas: Um ponto particularmente relevante é o uso concomitante com outros medicamentos ou produtos “naturais” sem que o paciente os inclua espontaneamente na história clínica. O terapeuta pode perceber mudanças abruptas de humor, sono, energia ou tolerabilidade após início de outro tratamento, sem que o paciente associe os eventos. Nesses casos, a confusão não é apenas entre efeito do fitoterápico e evolução do quadro, mas entre múltiplas intervenções ocorrendo ao mesmo tempo.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma aparente melhora inicial pode deslizar para expansividade, redução importante da necessidade de sono, aumento de impulsividade ou sensação de clareza excepcional. Na sessão, isso pode ser confundido com recuperação legítima, sobretudo se o paciente chega mais produtivo, confiante e menos inibido. O discriminador costuma estar na perda de freio, na aceleração e no afastamento do padrão habitual, mais do que no simples fato de estar melhor."

O que observar em sessão

- **Humor e baseline:** Pode surgir uma melhora parcial do humor, com menos choro, mais disposição para tarefas e algum alívio da desesperança, mas sem recuperação mais ampla da iniciativa, do prazer ou da capacidade de elaboração. Na sessão, isso às vezes aparece como um paciente menos sofrido e ao mesmo tempo ainda empobrecido afetivamente ou pouco engajado. A leitura pode se confundir com remissão espontânea, efeito de eventos de vida favoráveis ou oscilação natural de quadros leves, especialmente quando o início do uso não ficou bem datado.

Ativação e ansiedade: Em parte dos pacientes, o começo do uso pode coincidir com mais inquietação, irritabilidade, aceleração subjetiva ou pior tolerância a estímulos, o que na sessão pode parecer aumento de ansiedade habitual. Vale diferenciar se houve mudança qualitativa recente no ritmo da fala, na impaciência e na capacidade de permanecer em temas difíceis, em vez de apenas intensificação de um traço já conhecido. Também entram como confundidores cafeína, privação de sono, estressores recentes e outras substâncias usadas em paralelo.

Sono: O padrão de sono pode mudar nas primeiras semanas, com dificuldade para iniciar o sono, sono mais leve ou, em alguns casos, melhora secundária à redução do sofrimento depressivo. Em sessão, o terapeuta pode notar mais fadiga, menor tolerância à frustração ou oscilação de atenção, mas isso nem sempre aponta para piora do quadro de base. Quando o sono se altera perto do início, da interrupção ou de retomadas irregulares, a cronologia ajuda mais do que a intensidade isolada do sintoma.

Adesão e automanejo: Como se trata de um fitoterápico, não é raro que o paciente o use com lógica de experimento pessoal, suspenda quando se sente melhor, retome em momentos de piora ou alterne marcas sem considerar isso clinicamente relevante. Na sessão, esse padrão pode aparecer como narrativa fragmentada, dificuldade de datar mudanças e atribuições globais do tipo “acho que não fez diferença”. Isso pode ser confundido com ausência de resposta, quando na verdade a exposição foi irregular demais para permitir leitura clínica consistente.

Combinações silenciosas: Um ponto particularmente relevante é o uso concomitante com outros medicamentos ou produtos “naturais” sem que o paciente os inclua espontaneamente na história clínica. O terapeuta pode perceber mudanças abruptas de humor, sono, energia ou tolerabilidade após início de outro tratamento, sem que o paciente associe os eventos. Nesses casos, a confusão não é apenas entre efeito do fitoterápico e evolução do quadro, mas entre múltiplas intervenções ocorrendo ao mesmo tempo.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma aparente melhora inicial pode deslizar para expansividade, redução importante da necessidade de sono, aumento de impulsividade ou sensação de clareza excepcional. Na sessão, isso pode ser confundido com recuperação legítima, sobretudo se o paciente chega mais produtivo, confiante e menos inibido. O discriminador costuma estar na perda de freio, na aceleração e no afastamento do padrão habitual, mais do que no simples fato de estar melhor.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Fitoterápico usado sobretudo em quadros depressivos leves a moderados e, às vezes, por iniciativa própria do paciente antes de procurar tratamento psiquiátrico. No consultório, o ponto central costuma ser menos a resposta antidepressiva em si e mais a leitura do que mudou desde o início do uso: alguma melhora pode ser percebida ao longo de 2 a 6 semanas, enquanto interrupções, trocas de marca ou uso irregular podem embaralhar a linha de base. Como muitos pacientes o entendem como “natural”, vale observar adesão pouco consistente, automanejo silencioso e combinações com outros tratamentos sem que isso apareça espontaneamente na sessão.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que melhorou, essa melhora veio como mais calma e retomada gradual da rotina ou como uma aceleração fora do seu padrão, com menos sono e mais impulsividade? , As mudanças que você percebeu começaram de forma contínua depois que iniciou o uso ou aparecem mais em períodos em que você toma de um jeito e somem quando interrompe ou esquece? , Essa inquietação se parece com a sua ansiedade de costume ou tem algo diferente no corpo e no ritmo, como impaciência, agitação e dificuldade de desacelerar? , Seu sono piorou junto com preocupações e eventos recentes ou a mudança apareceu perto do início, da pausa ou da retomada do fitoterápico? , Você está usando mais alguma coisa ao mesmo tempo, mesmo produto natural, suplemento ou remédio de outra especialidade, desde que essas mudanças começaram? , O desinteresse e a apatia diminuíram de fato ou você sente mais energia, mas continua sem conseguir se envolver afetivamente com as coisas e com as pessoas?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve uso irregular
- interrupções frequentes ou retomadas por conta própria e isso impede entender a evolução clínica
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar melhor a cronologia e a adesão
- Quando surge aceleração importante
- redução da necessidade de sono
- impulsividade ou expansividade fora do padrão
- pode valer comunicar o médico para avaliar possível mudança de humor associada ao período de uso
- Quando há piora de ansiedade
- insônia ou irritabilidade logo após início
- retomada ou combinação com outros produtos
- pode valer contato com o médico para ajudar na discriminação clínica
- Quando o paciente menciona uso concomitante de outros medicamentos sem que isso estivesse claro até então
- pode valer alinhar com o médico porque a leitura do quadro fica mais incerta

Amarelo: alinhar em breve

- Quando
- após algumas semanas de uso aparentemente consistente
- não há melhora perceptível ou há piora funcional
- pode valer comunicar o médico para reavaliar o momento clínico e a condução do tratamento

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas ou após mudanças no uso
- aparecem ideação suicida nova ou claramente intensificada
- sobretudo em adolescentes e adultos jovens.: Fazer avaliação de risco na própria sessão e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente chega marcadamente acelerado
- dormindo muito menos sem cansaço
- com grandiosidade
- impulsividade ou perda de crítica fora do seu padrão.: Tratar como urgência clínica e buscar contato no mesmo dia com o médico assistente
- envolvendo rede de apoio e emergência se houver risco comportamental

Frase clínica

Com hipérico, o foco clínico costuma ser separar melhora parcial de automanejo irregular, combinações silenciosas e possível aceleração fora do baseline.

105 **HYPERICUM PERFORATUM L.**

Substância: Hypericum Perforatum L..

Nomes Comerciais: Hyperinat

Uso comum

- Hypericum perforatum L. é um fitoterápico usado sobretudo em quadros depressivos leves a moderados e, no consultório, costuma aparecer em pacientes que o percebem como alternativa “natural” a antidepressivos. Nas primeiras 2 a 4 semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto oscilação de humor, ansiedade, sono e adesão real; alguma mudança clínica, quando ocorre, costuma ser percebida ao longo de 4 a 6 semanas. O ponto central na sessão é não tomar “natural” como sinônimo de neutro: vale observar irregularidade de uso, automanejo sem comunicar a equipe, e mudanças de humor ou ativação que podem se confundir com evolução do quadro, eventos de vida ou uso concomitante de outras substâncias.

O paciente pode relatar

- **"Humor e resposta:** Na sessão, pode surgir melhora parcial do humor, maior disposição ou redução da desesperança, mas também frustração por resposta aquém do esperado após algumas semanas. A leitura clínica se complica quando a melhora coincide com alívio de estressores, retomada de rotina ou início de psicoterapia mais engajada. Também vale considerar uso irregular, interrupções silenciosas e expectativa de efeito rápido, que podem produzir a impressão de "não funcionou" ou de oscilação sem relação clara com a linha de base.

Ativação e ansiedade: Em parte dos pacientes, aparecem inquietação, aceleração subjetiva, irritabilidade ou sensação de estar "ligado demais", especialmente no início ou após mudanças no modo de uso feitas pelo próprio paciente. Isso pode se parecer com ansiedade habitual, reação a conflitos atuais ou até com um período de alívio depressivo vivido como energia recuperada. O que ajuda é observar se a ativação vem acompanhada de redução importante da necessidade de sono, impulsividade, fala mais pressionada ou mudança nítida do padrão da sessão.

Sono: O sono pode melhorar junto com o humor, mas também pode ficar mais leve, fragmentado ou encurtado quando há ativação. Na prática clínica, isso às vezes é confundido com insônia por estresse, uso de cafeína, mudança de rotina ou piora ansiosa independente do fitoterápico. Comparar o padrão atual com a baseline e com o horário em que o paciente refere usar a medicação ajuda a discriminar se há oscilação recente mais ampla ou apenas repercussão do momento de vida.

Adesão e automanejo: Como se trata de um produto percebido por muitos como menos "medicamentoso", é relativamente comum encontrar uso intermitente, esquecimento frequente, pausas por conta própria e associação com outros produtos sem que isso apareça espontaneamente no início da sessão. Esse padrão pode imitar recaída, ausência de resposta ou efeitos inconsistentes. Vale escutar com cuidado se o paciente nomeia o fitoterápico como tratamento de fato ou como algo acessório, porque essa representação costuma influenciar a adesão e a comunicação com o médico.

Interações no setting: O ponto mais sensível deste fitoterápico no consultório não é apenas o humor, mas o fato de frequentemente coexistir com outros medicamentos, suplementos ou automedicação. Quando surgem mudanças abruptas de ansiedade, agitação, mal-estar corporal ou piora pouco explicável após introdução de outra substância, a leitura exclusivamente psicodinâmica ou exclusivamente psiquiátrica pode empobrecer o caso. O terapeuta ganha precisão ao mapear a cronologia das mudanças sem assumir causalidade, registrando o que começou quando e com que impacto no padrão da sessão."

O que observar em sessão

- **Humor e resposta:** Na sessão, pode surgir melhora parcial do humor, maior disposição ou redução da desesperança, mas também frustração por resposta aquém do esperado após algumas semanas. A leitura clínica se complica quando a melhora coincide com alívio de estressores, retomada de rotina ou início de psicoterapia mais engajada. Também vale considerar uso irregular, interrupções silenciosas e expectativa de efeito rápido, que podem produzir a impressão de “não funcionou” ou de oscilação sem relação clara com a linha de base.

Ativação e ansiedade: Em parte dos pacientes, aparecem inquietação, aceleração subjetiva, irritabilidade ou sensação de estar “ligado demais”, especialmente no início ou após mudanças no modo de uso feitas pelo próprio paciente. Isso pode se parecer com ansiedade habitual, reação a conflitos atuais ou até com um período de alívio depressivo vivido como energia recuperada. O que ajuda é observar se a ativação vem acompanhada de redução importante da necessidade de sono, impulsividade, fala mais pressionada ou mudança nítida do padrão da sessão.

Sono: O sono pode melhorar junto com o humor, mas também pode ficar mais leve, fragmentado ou encurtado quando há ativação. Na prática clínica, isso às vezes é confundido com insônia por estresse, uso de cafeína, mudança de rotina ou piora ansiosa independente do fitoterápico. Comparar o padrão atual com a baseline e com o horário em que o paciente refere usar a medicação ajuda a discriminar se há oscilação recente mais ampla ou apenas repercussão do momento de vida.

Adesão e automanejo: Como se trata de um produto percebido por muitos como menos “medicamentoso”, é relativamente comum encontrar uso intermitente, esquecimento frequente, pausas por conta própria e associação com outros produtos sem que isso apareça espontaneamente no início da sessão. Esse padrão pode imitar recaída, ausência de resposta ou efeitos inconsistentes. Vale escutar com cuidado se o paciente nomeia o fitoterápico como tratamento de fato ou como algo acessório, porque essa representação costuma influenciar a adesão e a comunicação com o médico.

Interações no setting: O ponto mais sensível deste fitoterápico no consultório não é apenas o humor, mas o fato de frequentemente coexistir com outros medicamentos, suplementos ou automedicação. Quando surgem mudanças abruptas de ansiedade, agitação, mal-estar corporal ou piora pouco explicável após introdução de outra substância, a leitura exclusivamente psicodinâmica ou exclusivamente psiquiátrica pode empobrecer o caso. O terapeuta ganha precisão ao mapear a cronologia das mudanças sem assumir causalidade, registrando o que começou quando e com que impacto no padrão da sessão.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- *Hypericum perforatum* L. é um fitoterápico usado sobretudo em quadros depressivos leves a moderados e, no consultório, costuma aparecer em pacientes que o percebem como alternativa “natural” a antidepressivos. Nas primeiras 2 a 4 semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto oscilação de humor, ansiedade, sono e adesão real; alguma mudança clínica, quando ocorre, costuma ser percebida ao longo de 4 a 6 semanas. O ponto central na sessão é não tomar “natural” como sinônimo de neutro: vale observar irregularidade de uso, automanejo sem comunicar a equipe, e mudanças de humor ou ativação que podem se confundir com evolução do quadro, eventos de vida ou uso concomitante de outras substâncias.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais acelerado ou inquieto, isso parece a sua ansiedade de costume ou algo diferente no corpo e no ritmo do pensamento? , Essa melhora de humor veio junto com mais capacidade de sentir e elaborar as coisas, ou com uma sensação de ficar menos afetado por tudo? , Nos dias em que o sono encurta, você acorda cansado e preocupado, como numa fase ansiosa, ou desperta disposto e querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo? , Quando seu humor oscilou nas últimas semanas, isso aconteceu mesmo mantendo o uso do mesmo jeito, ou coincidiu com esquecimentos, pausas ou mudanças feitas por você? , Desde que começou a usar esse fitoterápico, entrou algum outro remédio, suplemento, chá ou substância que tenha mudado seu corpo, seu sono ou sua ansiedade? , Esse desinteresse ou afastamento que apareceu é mais uma queda global de energia e prazer, ou algo mais localizado na relação, no desejo ou no momento de vida?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve uso irregular
- pausas frequentes ou retomadas por conta própria e o quadro fica difícil de ler
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a cronologia clínica e reduzir confusão diagnóstica
- Quando surgem agitação
- irritabilidade
- redução importante do sono e aumento de impulsividade após o início do fitoterápico
- pode valer comunicar o médico para avaliar se há ativação clinicamente relevante
- Quando aparece piora abrupta ou mal-estar pouco explicável após introdução de outro medicamento
- suplemento ou substância
- pode valer alinhar com o médico assistente pela possibilidade de interação relevante
- Quando não há melhora perceptível após cerca de 4 a 6 semanas de uso que o paciente descreve como regular
- pode valer comunicar o médico para revisão do quadro e da estratégia terapêutica
- Quando efeitos subjetivos incômodos passam a ameaçar a continuidade silenciosa do tratamento

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico assistente para que a adesão não se rompa sem acompanhamento

Vermelho: tratar como urgência

- Surge ideação suicida nova ou claramente intensificada
- sobretudo nas primeiras semanas
- com desesperança
- agitação ou sensação de perda de controle.: Fazer avaliação de risco na hora e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Durante a sessão
- aparecem agitação intensa
- confusão
- tremores marcados
- sudorese importante e piora rápida do estado geral após combinação com outra substância.: Interromper o manejo habitual da sessão e orientar busca de avaliação médica imediata
- acionando suporte de urgência se houver rebaixamento clínico

Frase clínica

O foco clínico é discriminar melhora real, ativação e adesão irregular, sem subestimar o impacto de um fitoterápico percebido como “natural”.

106 CARBONATO DE LÍTIO

Substância: Carbonato de Lítio.

Nomes Comerciais: Carbolitium, Carbonato de Lítio, Literata, Carlit, Bilyt, Bipolit

Uso comum

- Carbonato de lítio é um estabilizador de humor que costuma aparecer no consultório em pacientes com transtorno bipolar e, às vezes, em quadros depressivos mais complexos acompanhados por psiquiatria. Para o terapeuta, a observação clínica ganha valor sobretudo nas primeiras semanas após início ou mudança recente de manejo, e também ao longo dos meses, quando adesão, rotina e tolerabilidade passam a influenciar o vínculo com o tratamento. Na sessão, o ponto central é diferenciar estabilização real de humor de lentificação, embotamento, oscilação residual ou uso irregular, além de reconhecer sinais físicos e cognitivos que, em conjunto, podem justificar contato mais rápido com o médico.

O paciente pode relatar

- **"Oscilação de humor:** Ao longo do acompanhamento, pode surgir redução da intensidade das oscilações, maior previsibilidade afetiva e menos impulsividade, o que às vezes é vivido como alívio e, em outras, como perda de vivacidade. Também pode haver persistência de flutuações, irritabilidade ou aceleração psíquica que confundem a leitura entre resposta parcial, curso do transtorno e impacto de eventos de vida. Na sessão, vale comparar com a linha de base recente e observar se a mudança aparece de modo consistente entre encontros ou em blocos ligados a sono, estresse e adesão.

Lentificação e cognição: Parte dos pacientes descreve pensamento mais lento, dificuldade para encontrar palavras, menor agilidade mental ou sensação de estar mais travado. Em sessão, isso pode aparecer como pausas maiores, menor espontaneidade associativa e esforço para sustentar elaboração, mas também pode se confundir com depressão, privação de sono, ansiedade intensa ou uso de outras medicações sedativas. A discriminação clínica depende de notar se houve estabilização do humor com custo cognitivo percebido ou se a lentificação acompanha rebaixamento global do quadro.

Sede e rotina corporal: Mudanças em sede, necessidade de beber água e aumento da frequência urinária podem atravessar a sessão de modo indireto, como interrupções, desconforto, preocupação prática e impacto na rotina de trabalho ou sono. Esses elementos às vezes são minimizados pelo paciente, mas podem influenciar adesão silenciosa e irritabilidade cotidiana. Também podem ser atribuídos apenas a hábitos, calor, dieta ou ansiedade, por isso vale situar quando começaram, quanto interferem e se vieram junto de outras mudanças cognitivas ou físicas.

Tremor e sinais físicos: Tremor fino nas mãos, sensação de fraqueza, náusea, mal-estar ou instabilidade podem aparecer como constrangimento, evitação de gestos, dificuldade para escrever ou segurar objetos, e não apenas como queixa espontânea. Na leitura clínica, esses sinais podem ser confundidos com ansiedade somática, efeito de cafeína, abstinência de álcool, exaustão ou outras condições clínicas. O que importa na sessão é o conjunto: intensidade, início recente, progressão e associação com confusão, diarreia, vômitos ou piora importante do funcionamento.

Adesão e ambivalência: Com o passar das semanas, é comum emergirem ambivalências ligadas à ideia de depender de medicação, ao medo de perder intensidade emocional ou ao incômodo com efeitos percebidos no corpo e na cognição. O paciente pode omitir falhas, reduzir por conta própria ou tomar de modo irregular sem nomear isso como interrupção, e então a sessão passa a mostrar oscilações difíceis de entender. Vale observar mudanças abruptas no padrão entre encontros, justificativas vagas para piora recente e discrepância entre discurso de adesão e sinais de uso inconsistente.

Virada de polaridade: Mesmo em uso de lítio, podem aparecer sinais de aceleração que lembram melhora, mas têm outra qualidade clínica: menos necessidade de sono, aumento de planos, expansividade, irritabilidade ou sensação de clareza excepcional. Em sessão, isso pode ser confundido com saída de depressão, retomada de autoestima ou entusiasmo diante de um evento positivo. A diferença costuma estar na velocidade, na perda de freio, no afastamento da

baseline e no quanto o paciente reconhece ou não estranheza no próprio estado."

O que observar em sessão

- **Oscilação de humor:** Ao longo do acompanhamento, pode surgir redução da intensidade das oscilações, maior previsibilidade afetiva e menos impulsividade, o que às vezes é vivido como alívio e, em outras, como perda de vivacidade. Também pode haver persistência de flutuações, irritabilidade ou aceleração psíquica que confundem a leitura entre resposta parcial, curso do transtorno e impacto de eventos de vida. Na sessão, vale comparar com a linha de base recente e observar se a mudança aparece de modo consistente entre encontros ou em blocos ligados a sono, estresse e adesão.

Lentificação e cognição: Parte dos pacientes descreve pensamento mais lento, dificuldade para encontrar palavras, menor agilidade mental ou sensação de estar "mais travado". Em sessão, isso pode aparecer como pausas maiores, menor espontaneidade associativa e esforço para sustentar elaboração, mas também pode se confundir com depressão, privação de sono, ansiedade intensa ou uso de outras medicações sedativas. A discriminação clínica depende de notar se houve estabilização do humor com custo cognitivo percebido ou se a lentificação acompanha rebaixamento global do quadro.

Sede e rotina corporal: Mudanças em sede, necessidade de beber água e aumento da frequência urinária podem atravessar a sessão de modo indireto, como interrupções, desconforto, preocupação prática e impacto na rotina de trabalho ou sono. Esses elementos às vezes são minimizados pelo paciente, mas podem influenciar adesão silenciosa e irritabilidade cotidiana. Também podem ser atribuídos apenas a hábitos, calor, dieta ou ansiedade, por isso vale situar quando começaram, quanto interferem e se vieram junto de outras mudanças cognitivas ou físicas.

Tremor e sinais físicos: Tremor fino nas mãos, sensação de fraqueza, náusea, mal-estar ou instabilidade podem aparecer como constrangimento, evitação de gestos, dificuldade para escrever ou segurar objetos, e não apenas como queixa espontânea. Na leitura clínica, esses sinais podem ser confundidos com ansiedade somática, efeito de cafeína, abstinência de álcool, exaustão ou outras condições clínicas. O que importa na sessão é o conjunto: intensidade, início recente, progressão e associação com confusão, diarreia, vômitos ou piora importante do funcionamento.

Adesão e ambivalência: Com o passar das semanas, é comum emergirem ambivalências ligadas à ideia de depender de medicação, ao medo de perder intensidade emocional ou ao incômodo com efeitos percebidos no corpo e na cognição. O paciente pode omitir falhas, reduzir por conta própria ou tomar de modo irregular sem nomear isso como interrupção, e então a sessão passa a mostrar oscilações difíceis de entender. Vale observar mudanças abruptas no padrão entre encontros, justificativas vagas para piora recente e discrepância entre discurso de adesão e sinais de uso inconsistente.

Virada de polaridade: Mesmo em uso de lítio, podem aparecer sinais de aceleração que lembram melhora, mas têm outra qualidade clínica: menos necessidade de sono, aumento de planos, expansividade, irritabilidade ou sensação de clareza excepcional. Em sessão, isso pode ser confundido com saída de depressão, retomada de autoestima ou entusiasmo diante de um evento positivo. A diferença costuma estar na velocidade, na perda de freio, no afastamento da

baseline e no quanto o paciente reconhece ou não estranheza no próprio estado.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Carbonato de lítio é um estabilizador de humor que costuma aparecer no consultório em pacientes com transtorno bipolar e, às vezes, em quadros depressivos mais complexos acompanhados por psiquiatria. Para o terapeuta, a observação clínica ganha valor sobretudo nas primeiras semanas após início ou mudança recente de manejo, e também ao longo dos meses, quando adesão, rotina e tolerabilidade passam a influenciar o vínculo com o tratamento. Na sessão, o ponto central é diferenciar estabilização real de humor de lentificação, embotamento, oscilação residual ou uso irregular, além de reconhecer sinais físicos e cognitivos que, em conjunto, podem justificar contato mais rápido com o médico.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está melhor, isso vem com mais estabilidade ao longo dos dias ou com uma aceleração que parece difícil de frear? , Essa sensação de estar mais lento aparece junto de tristeza e desânimo, ou você se sente emocionalmente mais estável apesar de pensar com menos agilidade? , As mudanças de humor que você percebe têm relação mais clara com acontecimentos da semana ou parecem surgir mesmo quando o contexto externo ficou parecido? , Quando sua rotina sai do eixo, o que muda primeiro: o sono, a tomada da medicação, a irritabilidade ou a clareza para pensar? , Esse desconforto físico que apareceu fica isolado ou veio junto de tremor mais forte, confusão, diarreia, vômitos ou sensação de desequilíbrio? , Nos dias em que você falha ou pensa em falhar no uso, o que pesa mais: incômodo corporal, sensação de estar apagado, resistência à ideia de tratamento ou esquecimento prático?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente mostra lentificação cognitiva ou embotamento que começam a comprometer trabalho
- estudo ou capacidade de elaboração em sessão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar impacto funcional e adesão
- Quando surgem tremor mais evidente
- náusea
- diarreia
- vômitos
- confusão ou instabilidade física em conjunto
- pode valer contato mais rápido com o médico pela possibilidade de um quadro que exige avaliação clínica
- Quando aparecem sinais de aceleração do humor
- redução importante da necessidade de sono
- expansividade ou irritabilidade fora da baseline
- pode valer comunicar o psiquiatra para discriminar possível virada de polaridade

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente admite uso irregular
- interrupções ou abandono silencioso por incômodo com efeitos percebidos
- pode valer alinhar com o médico para reduzir risco de descompensação e qualificar a leitura do quadro
- Quando
- após algumas semanas a meses de acompanhamento
- o humor segue muito instável sem relação clara com eventos de vida e sem melhora funcional perceptível
- pode valer comunicação para revisão clínica do caso

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente aparece confuso
- muito desorganizado
- com fala mais arrastada ou dificuldade incomum para se orientar
- especialmente se isso veio junto de tremor forte
- vômitos
- diarreia ou desequilíbrio.: Acionar avaliação médica no mesmo dia; se houver rebaixamento importante
- impossibilidade de autocuidado ou piora rápida
- mobilizar rede de apoio e emergência
- Surge aceleração marcante com pouca necessidade de sono
- aumento de impulsividade
- grandiosidade ou irritabilidade intensa
- em afastamento claro da baseline.: Contatar o psiquiatra no mesmo dia e avaliar necessidade de envolver rede de apoio
- sobretudo se houver risco financeiro
- sexual
- agressivo ou ruptura importante de juízo
- Aparece ideação suicida com intensificação recente
- desesperança acentuada ou sensação de perda de controle
- especialmente em contexto de oscilação rápida do humor.: Fazer manejo de risco na própria sessão e acionar psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- sem postergar para a próxima consulta

Frase clínica

Com lítio, o foco na terapia é distinguir estabilização de humor de lentificação, adesão irregular e sinais físicos que mudam a urgência clínica.

107 BROMIDRATO DE CITALOPRAM

Substância: Bromidrato de Citalopram.

Nomes Comerciais: Procimax, Citalopram, Città, Bromidrato de Citalopram, Denyl, Cipramil, Alcytam, Nypram

Uso comum

- O bromidrato de citalopram é um antidepressivo da classe dos ISRSs, encontrado com frequência em quadros depressivos e ansiosos. Na prática do consultório, as primeiras 1 a 2 semanas costumam concentrar piora subjetiva de ansiedade, inquietação, náusea, alteração do sono ou sensação de estranhamento, enquanto sinais de benefício tendem a ficar mais nítidos entre 3 e 6 semanas. Ao longo do seguimento, vale observar se a redução do sofrimento vem com maior acesso afetivo e retomada de funcionamento, ou se aparece um estado mais plano, apático ou sexualmente custoso, que pode ser confundido com melhora, recaída parcial ou desgaste relacional. Se houver interrupção irregular, alguns pacientes descrevem mal-estar em poucos dias.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais tensos, acelerados por dentro ou com sensação de inquietação que não coincide com o padrão habitual da ansiedade de base. Em sessão, isso pode aparecer como dificuldade de permanecer sentado, fala mais entrecortada ou menor tolerância ao silêncio. A leitura pode se confundir com estresse recente, expectativa em relação ao tratamento ou agravamento do próprio quadro ansioso; por isso, ajuda situar a mudança em relação à linha de base e à proximidade temporal do início do medicamento.

Humor e acesso afetivo: Quando o citalopram começa a ajudar, costuma haver redução de ruminação, menor peso subjetivo e alguma recuperação de iniciativa, mas nem sempre isso vem acompanhado de maior elaboração emocional. Em parte dos pacientes, o sofrimento diminui às custas de um certo achatamento, com menos reatividade e menos contato com nuances afetivas. Na sessão, importa diferenciar melhora clínica de um estado mais plano que pode ser lido como estabilidade, assim como distinguir isso de defesa psíquica, exaustão ou persistência depressiva com menos queixa verbal.

Sono e energia: Nas primeiras semanas, o sono pode oscilar para mais ou para menos, e a energia pode parecer desorganizada antes de se estabilizar. Alguns pacientes ficam mais cansados e lentificados; outros relatam sono mais leve, despertares ou sensação de estar 'ligados' demais à noite. Em consultório, isso pode se confundir com higiene do sono, uso de cafeína, sobrecarga de rotina ou com a própria depressão, que também altera sono e vitalidade; o ponto é observar se houve mudança de padrão após o início ou em fases de adesão irregular.

Sexualidade: Dificuldades de desejo, excitação ou orgasmo são clinicamente relevantes porque muitas vezes aparecem tardiamente na sessão, por vergonha ou por serem atribuídas a problemas do vínculo amoroso. O terapeuta pode notar afastamento do tema sexual, racionalizações ou aumento de conflito conjugal sem causa relacional suficientemente clara. Também aqui há confusão possível com depressão, ansiedade de desempenho, conflitos do casal e mudanças corporais ou hormonais; explorar a cronologia costuma ajudar a não reduzir a questão nem ao medicamento nem à dinâmica relacional.

Adesão e descontinuação: O uso irregular pode produzir oscilações que parecem instabilidade do quadro: um paciente que vinha mais estável volta subitamente mais sensível, tonto, irritado ou emocionalmente lábil sem um evento de vida proporcional. Em sessão, isso às vezes aparece como narrativa vaga sobre esquecimentos, interrupção por conta própria ou uso 'quando lembra', sobretudo quando houve efeitos incômodos ou sensação de já estar bem. A confusão mais comum é tomar essas flutuações como recaída depressiva ou fracasso terapêutico, quando a cronologia sugere descontinuidade.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma melhora inicial pode deslizar para um estado qualitativamente diferente: menos necessidade de sono, expansividade, irritabilidade incomum, aumento de impulsos e sensação de clareza ou potência fora do padrão. Na sessão, isso pode ser confundido com alívio legítimo após semanas de sofrimento, especialmente se o paciente descreve produtividade e bem-estar. O discriminante clínico costuma estar menos na intensidade da melhora e mais na mudança de ritmo, juízo e

necessidade de sono em relação ao baseline."

O que observar em sessão

- **Ansiedade inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais tensos, acelerados por dentro ou com sensação de inquietação que não coincide com o padrão habitual da ansiedade de base. Em sessão, isso pode aparecer como dificuldade de permanecer sentado, fala mais entrecortada ou menor tolerância ao silêncio. A leitura pode se confundir com estresse recente, expectativa em relação ao tratamento ou agravamento do próprio quadro ansioso; por isso, ajuda situar a mudança em relação à linha de base e à proximidade temporal do início do medicamento.

Humor e acesso afetivo: Quando o citalopram começa a ajudar, costuma haver redução de ruminação, menor peso subjetivo e alguma recuperação de iniciativa, mas nem sempre isso vem acompanhado de maior elaboração emocional. Em parte dos pacientes, o sofrimento diminui às custas de um certo achatamento, com menos reatividade e menos contato com nuances afetivas. Na sessão, importa diferenciar melhora clínica de um estado mais plano que pode ser lido como estabilidade, assim como distinguir isso de defesa psíquica, exaustão ou persistência depressiva com menos queixa verbal.

Sono e energia: Nas primeiras semanas, o sono pode oscilar para mais ou para menos, e a energia pode parecer desorganizada antes de se estabilizar. Alguns pacientes ficam mais cansados e lentificados; outros relatam sono mais leve, despertares ou sensação de estar 'ligados' demais à noite. Em consultório, isso pode se confundir com higiene do sono, uso de cafeína, sobrecarga de rotina ou com a própria depressão, que também altera sono e vitalidade; o ponto é observar se houve mudança de padrão após o início ou em fases de adesão irregular.

Sexualidade: Dificuldades de desejo, excitação ou orgasmo são clinicamente relevantes porque muitas vezes aparecem tardiamente na sessão, por vergonha ou por serem atribuídas a problemas do vínculo amoroso. O terapeuta pode notar afastamento do tema sexual, racionalizações ou aumento de conflito conjugal sem causa relacional suficientemente clara. Também aqui há confusão possível com depressão, ansiedade de desempenho, conflitos do casal e mudanças corporais ou hormonais; explorar a cronologia costuma ajudar a não reduzir a questão nem ao medicamento nem à dinâmica relacional.

Adesão e descontinuação: O uso irregular pode produzir oscilações que parecem instabilidade do quadro: um paciente que vinha mais estável volta subitamente mais sensível, tonto, irritado ou emocionalmente lábil sem um evento de vida proporcional. Em sessão, isso às vezes aparece como narrativa vaga sobre esquecimentos, interrupção por conta própria ou uso 'quando lembra', sobretudo quando houve efeitos incômodos ou sensação de já estar bem. A confusão mais comum é tomar essas flutuações como recaída depressiva ou fracasso terapêutico, quando a cronologia sugere descontinuidade.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma melhora inicial pode deslizar para um estado qualitativamente diferente: menos necessidade de sono, expansividade, irritabilidade incomum, aumento de impulsos e sensação de clareza ou potência fora do padrão. Na sessão, isso pode ser confundido com alívio legítimo após semanas de sofrimento, especialmente se o paciente descreve produtividade e bem-estar. O discriminante clínico costuma estar menos na intensidade da melhora e mais na mudança de ritmo, juízo e

necessidade de sono em relação ao baseline.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O bromidrato de citalopram é um antidepressivo da classe dos ISRSs, encontrado com frequência em quadros depressivos e ansiosos. Na prática do consultório, as primeiras 1 a 2 semanas costumam concentrar piora subjetiva de ansiedade, inquietação, náusea, alteração do sono ou sensação de estranhamento, enquanto sinais de benefício tendem a ficar mais nítidos entre 3 e 6 semanas. Ao longo do seguimento, vale observar se a redução do sofrimento vem com maior acesso afetivo e retomada de funcionamento, ou se aparece um estado mais plano, apático ou sexualmente custoso, que pode ser confundido com melhora, recaída parcial ou desgaste relacional. Se houver interrupção irregular, alguns pacientes descrevem mal-estar em poucos dias.

Perguntas úteis

- "Essa inquietação que apareceu se parece com a sua ansiedade de costume ou é mais uma sensação corporal de não conseguir ficar parado, diferente do que você já conhecia? , Quando você diz que está melhor, você se sente mais disponível por dentro e mais capaz de viver as coisas, ou mais indiferente e 'anestesiado' diante delas? , As mudanças no sono e na energia começaram junto com alguma fase do uso mais regular ou mais irregular, ou combinam melhor com algo que estava acontecendo na sua rotina? , Na sexualidade, a dificuldade parece mais ligada ao vínculo e ao contexto com a outra pessoa, ou surgiu como uma mudança do seu corpo e da sua resposta mesmo quando o interesse afetivo está preservado? , Esse período de mais disposição veio com recuperação do seu funcionamento habitual, ou com menos necessidade de dormir, mais impulsividade e uma aceleração que foge do seu padrão? , Quando você piorou de repente, houve também esquecimentos, pausas ou dias em que você deixou de tomar, ou a mudança pareceu independente disso?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta inquietação importante
- piora nítida da ansiedade ou insônia persistente logo após o início
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar efeito inicial de agravamento do quadro e reduzir risco de abandono silencioso
- Quando surge embotamento afetivo relevante
- com redução do sofrimento mas também empobrecimento do contato emocional e prejuízo funcional ou relacional
- pode valer comunicar o médico assistente para situar a mudança no conjunto do tratamento
- Quando dificuldades sexuais passam a afetar vínculo
- autoestima ou adesão
- pode valer alinhar com o psiquiatra porque esse é um motivo frequente de uso irregular ou interrupção sem aviso
- Quando há oscilação clínica abrupta em contexto de esquecimentos

Amarelo: alinhar em breve

- pausas ou interrupção por conta própria
- pode valer contato com o médico assistente para esclarecer se a instabilidade acompanha adesão irregular
- Quando o paciente entra em estado de aceleração incomum
- com menos sono
- irritabilidade ou expansividade fora do padrão
- pode valer comunicação com o psiquiatra para avaliar possível mudança qualitativa do humor
- Quando
- após cerca de 4 a 6 semanas de uso aparentemente regular
- não se observa qualquer sinal de benefício subjetivo ou funcional
- pode valer alinhar com o médico assistente para atualização da leitura clínica

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a falar em morte
- desesperança extrema ou intenção de se ferir de modo mais intenso ou mais organizado do que sua linha de base.: Avalie risco imediatamente
- acione o psiquiatra no mesmo dia e mobilize rede de apoio e emergência quando necessário
- A sessão mostra mudança brusca para muito menos sono
- fala acelerada
- grandiosidade
- irritabilidade incomum ou impulsos que fogem claramente do padrão do paciente.: Trate como urgência clínica
- registre a mudança observável e contate o psiquiatra no mesmo dia; se houver risco comportamental
- acione rede de apoio e emergência

Frase clínica

No citalopram, o foco é distinguir melhora real de ativação inicial, embotamento afetivo, custo sexual e oscilações ligadas à adesão.

108 CITALOPRAM

Substância: Citalopram.

Nomes Comerciais: Citalopram, Maxapran, Citalopram (Port. 344/98, L-C1)

Uso comum

- Citalopram é um antidepressivo ISRS que costuma aparecer em pacientes com depressão e quadros ansiosos. Na terapia, as primeiras 1 a 2 semanas merecem atenção para piora subjetiva de ansiedade, inquietação, náusea, sono mais irregular ou sensação de estranhamento, antes de eventual benefício clínico; sinais de melhora costumam ficar mais nítidos entre 4 e 8 semanas. Se houver uso irregular ou interrupção abrupta, nos dias seguintes podem surgir tontura, mal-estar, irritabilidade, sensação de instabilidade e piora emocional que podem se confundir com recaída. O ponto central em sessão é diferenciar ativação inicial, resposta parcial, embotamento afetivo e descontinuação de mudanças do próprio quadro ou de eventos de vida.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais tensos, inquietos ou com sensação de aceleração interna, mesmo quando procuravam tratamento justamente para ansiedade. Em sessão, isso pode aparecer como dificuldade de permanecer sentado, fala mais apressada, menor tolerância ao silêncio ou aumento de monitoramento corporal. Vale não concluir de imediato que se trata apenas de piora do transtorno de base: a coincidência temporal com início recente, retomada após falhas de adesão ou mudanças importantes na rotina ajuda a discriminar hipóteses.

Humor e resposta: Ao longo das semanas, pode surgir melhora gradual de humor, redução de ruminação e maior disponibilidade para tarefas, mas às vezes o paciente descreve apenas um amortecimento do sofrimento sem recuperação clara de interesse ou vitalidade. Na sessão, isso pode se traduzir em menos choro e menos desespero, porém com narrativa ainda empobrecida, pouca iniciativa e sensação de estar funcionando no automático. A leitura pode se confundir tanto com resposta parcial ao tratamento quanto com remissão espontânea, alívio por mudança externa ou oscilação própria do episódio depressivo.

Embotamento afetivo: Parte dos pacientes refere sentir-se menos reativo emocionalmente, o que pode ser vivido como alívio ou como perda de intensidade afetiva. O terapeuta pode notar discurso mais plano, menor acesso a tristeza e alegria, redução de ambivalência e elaboração mais intelectualizada, sem que isso signifique necessariamente piora. Esse quadro pode ser confundido com melhora consistente do humor, defesa dissociativa, exaustão emocional ou retraimento vincular, especialmente quando o paciente valoriza muito “não sentir” como sinal de estar melhor.

Sono e energia: O padrão de sono pode oscilar nas primeiras semanas: alguns pacientes ficam mais sonolentos e lentificados, outros mais despertos ou com sono fragmentado. Em sessão, isso aparece como bocejos, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade por noites ruins ou relato de cansaço sem clareza se houve melhora do humor. A distinção com depressão em curso, sobrecarga de trabalho, uso de cafeína, álcool ou outras medicações depende de mapear o ritmo temporal e a relação entre sono, energia diurna e funcionamento.

Sexualidade: Redução de desejo, dificuldade de excitação ou atraso para chegar ao orgasmo podem surgir e muitas vezes aparecem primeiro como afastamento do parceiro, culpa ou evitação do tema. O terapeuta pode notar mudança no investimento erótico, constrangimento ao falar de intimidade ou interpretação relacional de algo que talvez não seja apenas do vínculo. Também aqui a leitura pede cuidado: conflitos conjugais, depressão, ansiedade de desempenho e imagem corporal podem produzir apresentação semelhante e às vezes coexistem.

Adesão e descontinuação: Citalopram pode ser abandonado silenciosamente quando o paciente se sente melhor, quando os efeitos iniciais incomodam ou quando surgem impactos na sexualidade. Na sessão, isso costuma aparecer como oscilação abrupta entre encontros, retorno de irritabilidade, tontura, sensação de “corpo estranho”, instabilidade emocional ou explicações vagas sobre esquecimento. Sem perguntar diretamente sobre regularidade de uso, o terapeuta pode interpretar como recaída, resistência ao processo ou reação a eventos de vida, quando a irregularidade é parte importante do quadro."

O que observar em sessão

- **Ansiedade inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais tensos, inquietos ou com sensação de aceleração interna, mesmo quando procuravam tratamento justamente para ansiedade. Em sessão, isso pode aparecer como dificuldade de permanecer sentado, fala mais apressada, menor tolerância ao silêncio ou aumento de monitoramento corporal. Vale não concluir de imediato que se trata apenas de piora do transtorno de base: a coincidência temporal com início recente, retomada após falhas de adesão ou mudanças importantes na rotina ajuda a discriminar hipóteses.

Humor e resposta: Ao longo das semanas, pode surgir melhora gradual de humor, redução de ruminação e maior disponibilidade para tarefas, mas às vezes o paciente descreve apenas um amortecimento do sofrimento sem recuperação clara de interesse ou vitalidade. Na sessão, isso pode se traduzir em menos choro e menos desespero, porém com narrativa ainda empobrecida, pouca iniciativa e sensação de estar funcionando no automático. A leitura pode se confundir tanto com resposta parcial ao tratamento quanto com remissão espontânea, alívio por mudança externa ou oscilação própria do episódio depressivo.

Embotamento afetivo: Parte dos pacientes refere sentir-se menos reativo emocionalmente, o que pode ser vivido como alívio ou como perda de intensidade afetiva. O terapeuta pode notar discurso mais plano, menor acesso a tristeza e alegria, redução de ambivalência e elaboração mais intelectualizada, sem que isso signifique necessariamente piora. Esse quadro pode ser confundido com melhora consistente do humor, defesa dissociativa, exaustão emocional ou retraimento vincular, especialmente quando o paciente valoriza muito “não sentir” como sinal de estar melhor.

Sono e energia: O padrão de sono pode oscilar nas primeiras semanas: alguns pacientes ficam mais sonolentos e lentificados, outros mais despertos ou com sono fragmentado. Em sessão, isso aparece como bocejos, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade por noites ruins ou relato de cansaço sem clareza se houve melhora do humor. A distinção com depressão em curso, sobrecarga de trabalho, uso de cafeína, álcool ou outras medicações depende de mapear o ritmo temporal e a relação entre sono, energia diurna e funcionamento.

Sexualidade: Redução de desejo, dificuldade de excitação ou atraso para chegar ao orgasmo podem surgir e muitas vezes aparecem primeiro como afastamento do parceiro, culpa ou evitação do tema. O terapeuta pode notar mudança no investimento erótico, constrangimento ao falar de intimidade ou interpretação relacional de algo que talvez não seja apenas do vínculo. Também aqui a leitura pede cuidado: conflitos conjugais, depressão, ansiedade de desempenho e imagem corporal podem produzir apresentação semelhante e às vezes coexistem.

Adesão e descontinuação: Citalopram pode ser abandonado silenciosamente quando o paciente se sente melhor, quando os efeitos iniciais incomodam ou quando surgem impactos na sexualidade. Na sessão, isso costuma aparecer como oscilação abrupta entre encontros, retorno de irritabilidade, tontura, sensação de “corpo estranho”, instabilidade emocional ou explicações vagas sobre esquecimento. Sem perguntar diretamente sobre regularidade de uso, o terapeuta pode interpretar como recaída, resistência ao processo ou reação a eventos de vida, quando a irregularidade é parte importante do quadro.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Citalopram é um antidepressivo ISRS que costuma aparecer em pacientes com depressão e quadros ansiosos. Na terapia, as primeiras 1 a 2 semanas merecem atenção para piora subjetiva de ansiedade, inquietação, náusea, sono mais irregular ou sensação de estranhamento, antes de eventual benefício clínico; sinais de melhora costumam ficar mais nítidos entre 4 e 8 semanas. Se houver uso irregular ou interrupção abrupta, nos dias seguintes podem surgir tontura, mal-estar, irritabilidade, sensação de instabilidade e piora emocional que podem se confundir com recaída. O ponto central em sessão é diferenciar ativação inicial, resposta parcial, embotamento afetivo e descontinuação de mudanças do próprio quadro ou de eventos de vida.

Perguntas úteis

- "Essa piora da ansiedade começou junto com algum estressor específico ou apareceu mais como uma agitação corporal sem um pensamento dominante acompanhando? , Quando você diz que está melhor, sente que voltou a se interessar e se envolver com as coisas ou está mais sem sofrimento, porém também mais sem intensidade? , Nos dias em que se sente estranho ou mais instável, isso veio depois de algum esquecimento, pausa ou mudança no jeito de tomar a medicação? , Seu cansaço tem cara de sono ruim e lentidão do corpo ou parece mais aquela falta de vontade e peso depressivo que você já conhecia? , Na sua vida sexual, a mudança parece mais ligada ao vínculo e ao desejo pelo parceiro ou ao funcionamento do corpo mesmo quando há interesse? , Essa aceleração que apareceu parece com sua ansiedade habitual, cheia de preocupações, ou é mais uma inquietação nova, difícil de nomear e de descarregar?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente relata abandono silencioso
- uso muito irregular ou interrupção por conta própria
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se a oscilação clínica coincide com descontinuação
- Quando a ansiedade
- a inquietação ou a insônia se intensificam nas primeiras semanas a ponto de comprometer funcionamento
- vínculo ou continuidade do tratamento
- pode valer comunicação para avaliação clínica do curso inicial
- Quando surgem queixas sexuais persistentes que aumentam evitação
- conflito conjugal ou risco de abandono do medicamento
- pode valer alinhar com o médico pela relevância para adesão
- Quando após 6 a 8 semanas não se observa melhora minimamente consistente de humor
- ansiedade ou funcionamento
- apesar de uso aparentemente regular
- pode valer comunicação para revisão do quadro
- Quando aparece elevação incomum de energia

Amarelo: alinhar em breve

- redução importante da necessidade de sono
- impulsividade ou expansividade fora do padrão do paciente
- pode valer contato com o médico para avaliar mudança de estado de humor

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a falar em morte
- desesperança ou autoagressão com aumento de urgência
- planejamento ou perda de freios.: Avalie risco imediatamente
- acione psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhe para emergência quando houver risco iminente
- Surge mudança abrupta para euforia incomum
- fala muito acelerada
- pouca necessidade de sono
- grandiosidade ou impulsividade marcante fora da linha de base.: Contate o médico assistente no mesmo dia e organize contenção clínica e rede de apoio conforme o grau de desorganização e risco

Frase clínica

No citalopram, o foco é separar ativação inicial, resposta parcial, embotamento afetivo e descontinuação de mudanças do próprio quadro.

109 CLORIDRATO DE FLUOXETINA

Substância: Cloridrato de Fluoxetina.

Nomes Comerciais: Verotina, Fluxene, Cloridrato de Fluoxetina, Fluoxetin, Prozen, Prozac, Daforin

Uso comum

- A fluoxetina é um antidepressivo de uso frequente em depressão, transtornos de ansiedade, TOC e alguns quadros alimentares. No consultório, costuma importar menos a classe em si e mais o padrão temporal: nas primeiras 1 a 3 semanas podem aparecer ativação, inquietação, piora subjetiva da ansiedade, alterações de sono ou desconfortos que testam a adesão; a resposta clínica costuma começar a se delinear ao longo de 4 a 6 semanas, às vezes mais em sintomas obsessivos. Pela meia-vida longa, oscilações por esquecimento ou interrupção podem ser menos abruptas do que com outros antidepressivos, o que às vezes encobre adesão irregular. O foco na sessão é diferenciar ativação inicial, melhora real do humor, embotamento, efeitos sexuais e sinais de virada de humor em pacientes vulneráveis.

O paciente pode relatar

- **"Ativação inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais acelerados, inquietos, com sensação de estar "ligados", mais ansiosos ou com pior tolerância ao silêncio e à espera. Em sessão, isso pode aparecer como fala mais rápida, dificuldade de se deter na elaboração e aumento da urgência subjetiva, o que pode ser confundido tanto com agravamento do quadro ansioso quanto com reação a eventos recentes. Vale observar a relação temporal com o início do medicamento e se a ativação é difusa ao longo do dia ou reativa a temas específicos da sessão, porque adesão irregular e uso intermitente também podem produzir um padrão instável.

Humor e resposta: Quando há resposta terapêutica, o paciente pode relatar menos desesperança, maior disponibilidade para tarefas e algum retorno de interesse, mas nem sempre isso vem acompanhado de elaboração emocional mais rica. Em parte dos casos, a melhora inicial é mais comportamental do que afetiva, e o terapeuta pode se perguntar se houve ganho real de baseline ou apenas redução da inibição. Também convém não atribuir toda melhora ao medicamento: mudanças ambientais, alívio de crise aguda e retomada de rotina podem produzir um quadro semelhante nas mesmas semanas.

Ansiedade e pânico: A fluoxetina costuma aparecer em pacientes com ansiedade importante, e o início do tratamento pode coincidir com aumento transitório de apreensão, insônia ou sensações corporais que o paciente lê como piora global. Na sessão, isso pode se misturar ao padrão habitual de hipervigilância, a medo de depender de medicação ou a experiências prévias ruins com tratamento. A discriminação clínica ganha precisão quando se observa se a ansiedade está mais corporal e inespecífica do que o costume, se surgiu perto do início do uso e se houve flutuação associada a esquecimentos ou retomadas.

Sono e energia: Alguns pacientes ficam mais despertos, com dificuldade para iniciar o sono ou sensação de sono mais leve; outros descrevem cansaço, especialmente quando a ansiedade de base segue alta. Em sessão, tanto a insônia quanto a fadiga podem ser lidas apressadamente como piora depressiva, quando às vezes refletem fase inicial de adaptação, rotina desorganizada ou comorbidades clínicas. O ponto útil é comparar com a linha de base anterior ao início do medicamento e com a distribuição da energia ao longo da semana, porque a oscilação nem sempre acompanha a narrativa afetiva do paciente.

Sexualidade: Redução de desejo, dificuldade de excitação ou atraso para chegar ao orgasmo podem surgir e frequentemente ficam fora do relato espontâneo, seja por vergonha, seja porque o paciente atribui a mudança ao relacionamento ou ao próprio quadro depressivo. Na terapia, isso pode aparecer como afastamento do parceiro, queda de autoestima ou leitura de "anestesia" afetiva. A distinção importa porque, quando o vínculo está preservado e a mudança sexual coincide com o tratamento, aumenta a chance de o incômodo estar pesando na adesão silenciosa.

Embotamento afetivo: Em alguns casos, o paciente melhora da angústia, mas passa a se perceber mais "chapado", menos tocado pelas coisas ou com acesso afetivo reduzido. Na sessão, isso pode ser confundido com remissão saudável de ruminação, defesa dissociativa ou retraimento depressivo residual. O terapeuta ganha mais clareza ao observar se houve redução do sofrimento com preservação de interesse e vínculo, ou se a diminuição da dor veio junto de

empobrecimento da experiência emocional e da responsividade interpessoal.

Adesão e interrupção: Como a fluoxetina tende a produzir menos descontinuação abrupta perceptível do que outros antidepressivos, o paciente pode faltar com regularidade ao uso sem notar imediatamente uma mudança nítida, o que dificulta a leitura clínica. Em sessão, isso aparece como resposta parcial errática, semanas “boas e ruins” sem gatilho claro ou narrativa de que o remédio “não faz diferença”, apesar de uso inconsistente. Também é um contexto em que efeitos sexuais, ativação inicial ou sensação de melhora suficiente podem favorecer abandono silencioso sem comunicação ao médico."

O que observar em sessão

- **Ativação inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais acelerados, inquietos, com sensação de estar “ligados”, mais ansiosos ou com pior tolerância ao silêncio e à espera. Em sessão, isso pode aparecer como fala mais rápida, dificuldade de se deter na elaboração e aumento da urgência subjetiva, o que pode ser confundido tanto com agravamento do quadro ansioso quanto com reação a eventos recentes. Vale observar a relação temporal com o início do medicamento e se a ativação é difusa ao longo do dia ou reativa a temas específicos da sessão, porque adesão irregular e uso intermitente também podem produzir um padrão instável.

Humor e resposta: Quando há resposta terapêutica, o paciente pode relatar menos desesperança, maior disponibilidade para tarefas e algum retorno de interesse, mas nem sempre isso vem acompanhado de elaboração emocional mais rica. Em parte dos casos, a melhora inicial é mais comportamental do que afetiva, e o terapeuta pode se perguntar se houve ganho real de baseline ou apenas redução da inibição. Também convém não atribuir toda melhora ao medicamento: mudanças ambientais, alívio de crise aguda e retomada de rotina podem produzir um quadro semelhante nas mesmas semanas.

Ansiedade e pânico: A fluoxetina costuma aparecer em pacientes com ansiedade importante, e o início do tratamento pode coincidir com aumento transitório de apreensão, insônia ou sensações corporais que o paciente lê como piora global. Na sessão, isso pode se misturar ao padrão habitual de hipervigilância, a medo de depender de medicação ou a experiências prévias ruins com tratamento. A discriminação clínica ganha precisão quando se observa se a ansiedade está mais corporal e inespecífica do que o costume, se surgiu perto do início do uso e se houve flutuação associada a esquecimentos ou retomadas.

Sono e energia: Alguns pacientes ficam mais despertos, com dificuldade para iniciar o sono ou sensação de sono mais leve; outros descrevem cansaço, especialmente quando a ansiedade de base segue alta. Em sessão, tanto a insônia quanto a fadiga podem ser lidas apressadamente como piora depressiva, quando às vezes refletem fase inicial de adaptação, rotina desorganizada ou comorbidades clínicas. O ponto útil é comparar com a linha de base anterior ao início do medicamento e com a distribuição da energia ao longo da semana, porque a oscilação nem sempre acompanha a narrativa afetiva do paciente.

Sexualidade: Redução de desejo, dificuldade de excitação ou atraso para chegar ao orgasmo podem surgir e frequentemente ficam fora do relato espontâneo, seja por vergonha, seja porque o paciente atribui a mudança ao relacionamento ou ao próprio quadro depressivo. Na terapia, isso pode aparecer como afastamento do parceiro, queda de autoestima ou leitura de “anestesia” afetiva. A distinção importa porque, quando o vínculo está preservado e a mudança sexual coincide com o tratamento, aumenta a chance de o incômodo estar pesando na adesão silenciosa.

Embotamento afetivo: Em alguns casos, o paciente melhora da angústia, mas passa a se perceber mais “chapado”, menos tocado pelas coisas ou com acesso afetivo reduzido. Na sessão, isso pode ser confundido com remissão saudável de ruminação, defesa dissociativa ou retraimento depressivo residual. O terapeuta ganha mais clareza ao observar se houve redução do sofrimento com preservação de interesse e vínculo, ou se a diminuição da dor veio junto de

empobrecimento da experiência emocional e da responsividade interpessoal.

Adesão e interrupção: Como a fluoxetina tende a produzir menos descontinuação abrupta perceptível do que outros antidepressivos, o paciente pode faltar com regularidade ao uso sem notar imediatamente uma mudança nítida, o que dificulta a leitura clínica. Em sessão, isso aparece como resposta parcial errática, semanas “boas e ruins” sem gatilho claro ou narrativa de que o remédio “não faz diferença”, apesar de uso inconsistente. Também é um contexto em que efeitos sexuais, ativação inicial ou sensação de melhora suficiente podem favorecer abandono silencioso sem comunicação ao médico.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A fluoxetina é um antidepressivo de uso frequente em depressão, transtornos de ansiedade, TOC e alguns quadros alimentares. No consultório, costuma importar menos a classe em si e mais o padrão temporal: nas primeiras 1 a 3 semanas podem aparecer ativação, inquietação, piora subjetiva da ansiedade, alterações de sono ou desconfortos que testam a adesão; a resposta clínica costuma começar a se delinear ao longo de 4 a 6 semanas, às vezes mais em sintomas obsessivos. Pela meia-vida longa, oscilações por esquecimento ou interrupção podem ser menos abruptas do que com outros antidepressivos, o que às vezes encobre adesão irregular. O foco na sessão é diferenciar ativação inicial, melhora real do humor, embotamento, efeitos sexuais e sinais de virada de humor em pacientes vulneráveis.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está mais acelerado, isso parece uma ansiedade parecida com a de antes ou uma agitação mais corporal, como se fosse difícil desacelerar mesmo sem um motivo claro? , Essa melhora que você percebe veio com mais interesse e presença nas coisas, ou mais como um alívio da dor com você se sentindo meio distante e menos tocado? , Nos dias em que o sono piora, você se sente mais cansado e para baixo no dia seguinte, ou mais ligado e inquieto apesar de ter dormido menos? , Na sua vida sexual, a mudança parece mais ligada ao vínculo e ao desejo pelo parceiro, ou ao funcionamento do corpo ter mudado mesmo quando o interesse afetivo continua? , Essas oscilações da semana aconteceram mesmo com uma rotina parecida, ou coincidiram com dias em que você esqueceu, pulou ou retomou o medicamento? , Esse aumento de energia veio junto de mais organização e clareza, ou com impulsividade, menos necessidade de sono e sensação de estar diferente do seu jeito habitual?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta ativação importante nas primeiras semanas
- com ansiedade mais intensa
- insônia ou inquietação que começam a ameaçar a continuidade do tratamento
- pode valer alinhar com o psiquiatra para avaliação de tolerabilidade e adesão
- Quando surge redução importante de desejo
- excitação ou orgasmo e isso começa a afetar vínculo
- autoestima ou manutenção silenciosa do uso

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicar o médico assistente pela relevância clínica para adesão
- Quando a melhora após 4 a 6 semanas permanece muito parcial ou errática e a sessão sugere uso inconsistente
- pode valer contato com o psiquiatra para alinhar leitura clínica e adesão
- Quando aparecem sinais de possível virada de humor
- como energia muito aumentada
- fala pressionada
- menor necessidade de sono e expansividade fora do padrão
- pode valer comunicação rápida com o médico pela mudança de estado mental
- Quando o paciente interrompeu por conta própria e retorna com piora subjetiva
- oscilação importante ou confusão sobre o que mudou
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar o momento clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a relatar ideação suicida nova ou mais intensa
- com maior impulso
- planejamento ou sensação de perda de controle.: Avalie risco imediatamente
- acione psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhe para emergência quando houver risco iminente
- O paciente chega muito mais acelerado que o habitual
- dormindo pouco sem cansaço
- com fala pressionada
- grandiosidade ou impulsividade marcante.: Considere mudança aguda de estado mental
- registre os achados e busque contato com o psiquiatra no mesmo dia; acione suporte de urgência se houver risco comportamental

Frase clínica

Na fluoxetina, o centro da observação é separar ativação inicial, melhora real, embotamento e adesão irregular sem perder sinais de virada de humor.

110 CLORIDRATO DE PAROXETINA

Substância: Cloridrato de Paroxetina.

Nomes Comerciais: Cebrilin, Pondera, Cloridrato de Paroxetina, Aropax, Paxil Cr, Roxetin, Parox

Uso comum

- A paroxetina é um antidepressivo da classe dos ISRSs, encontrado com frequência em pacientes em tratamento de depressão, transtornos de ansiedade, pânico, fobia social, TOC e TEPT. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta pode acompanhar oscilação entre discreta ativação, náusea, piora subjetiva da ansiedade ou sonolência, antes de mudanças mais consistentes no humor e na ansiedade, que costumam ficar mais legíveis entre 4 e 8 semanas. Nesta substância, vale atenção especial a embotamento afetivo, impacto sexual e sinais de uso irregular, porque interrupções de poucos dias podem coincidir com mal-estar, tontura, irritabilidade e sensação de “estranheza”, facilmente confundidos com recaída ou crise do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais inquietos, com sensação de tensão interna, piora transitória da ansiedade ou maior sensibilidade corporal, o que pode ser lido apressadamente como agravamento do transtorno. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais apreensiva, foco aumentado em sensações físicas e menor capacidade de elaboração. Vale situar se houve mudança recente no medicamento, porque esse início pode se misturar a estressores da semana, expectativa catastrófica sobre o tratamento ou flutuação habitual do quadro ansioso.

Humor e embotamento: Com a evolução do tratamento, pode haver melhora do sofrimento depressivo e da reatividade ansiosa, mas em parte dos pacientes surge uma experiência de amortecimento afetivo: menos dor, porém também menos acesso a alegria, desejo ou comoção. Em sessão, isso pode aparecer como narrativa mais plana, menor ressonância emocional e sensação de estar "funcionando no automático". O ponto clínico é diferenciar se houve ganho de estabilidade com preservação de vitalidade, se há embotamento associado ao medicamento, ou se o achatamento já fazia parte do episódio depressivo em curso.

Sono e energia: A paroxetina pode coincidir com mais sonolência, lentificação subjetiva ou cansaço, sobretudo no início, embora alguns pacientes descrevam fragmentação do sono por ansiedade residual. No consultório, isso pode aparecer como menor prontidão associativa, bocejos, atraso psicomotor leve ou dificuldade de sustentar atenção. Convém contrastar com a linha de base: sedação medicamentosa, piora depressiva, privação de sono por rotina e uso concomitante de outras medicações podem produzir apresentações semelhantes.

Sexualidade: Alterações de libido, excitação e orgasmo têm relevância clínica particular com esta substância e nem sempre surgem espontaneamente no relato, embora possam afetar vínculo, autoestima e adesão silenciosa. Em sessão, o tema às vezes aparece deslocado para conflitos conjugais, evitação de intimidade ou sensação de inadequação. A discriminação importante é entre efeito associado ao tratamento, retraimento afetivo do episódio depressivo, tensão relacional prévia ou mudança mais ampla na dinâmica do casal.

Adesão e descontinuação: A paroxetina merece atenção especial à regularidade de uso, porque esquecimentos, interrupção por conta própria ou tomada errática podem ser seguidos em poucos dias por tontura, mal-estar, irritabilidade, sensação de choque no corpo, choro fácil ou estranheza subjetiva. Na sessão, isso pode parecer recaída abrupta, crise ansiosa sem gatilho claro ou desorganização emocional inesperada. Quando o padrão temporal é muito súbito e coincide com falhas de uso, vale registrar essa hipótese antes de concluir que houve piora primária do transtorno.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma melhora inicial pode se confundir com aceleração patológica do humor. O terapeuta pode notar redução importante da necessidade de sono, fala pressionada, aumento de planos, irritabilidade incomum, expansividade ou autoconfiança pouco habitual para a linha de base. O desafio é distinguir alívio legítimo após semanas de sofrimento de uma mudança qualitativa do estado mental que pede comunicação mais rápida com o médico assistente."

O que observar em sessão

- **Ansiedade inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais inquietos, com sensação de tensão interna, piora transitória da ansiedade ou maior sensibilidade corporal, o que pode ser lido apressadamente como agravamento do transtorno. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais apreensiva, foco aumentado em sensações físicas e menor capacidade de elaboração. Vale situar se houve mudança recente no medicamento, porque esse início pode se misturar a estressores da semana, expectativa catastrófica sobre o tratamento ou flutuação habitual do quadro ansioso.

Humor e embotamento: Com a evolução do tratamento, pode haver melhora do sofrimento depressivo e da reatividade ansiosa, mas em parte dos pacientes surge uma experiência de amortecimento afetivo: menos dor, porém também menos acesso a alegria, desejo ou comoção. Em sessão, isso pode aparecer como narrativa mais plana, menor ressonância emocional e sensação de estar “funcionando no automático”. O ponto clínico é diferenciar se houve ganho de estabilidade com preservação de vitalidade, se há embotamento associado ao medicamento, ou se o achatamento já fazia parte do episódio depressivo em curso.

Sono e energia: A paroxetina pode coincidir com mais sonolência, lentificação subjetiva ou cansaço, sobretudo no início, embora alguns pacientes descrevam fragmentação do sono por ansiedade residual. No consultório, isso pode aparecer como menor prontidão associativa, bocejos, atraso psicomotor leve ou dificuldade de sustentar atenção. Convém contrastar com a linha de base: sedação medicamentosa, piora depressiva, privação de sono por rotina e uso concomitante de outras medicações podem produzir apresentações semelhantes.

Sexualidade: Alterações de libido, excitação e orgasmo têm relevância clínica particular com esta substância e nem sempre surgem espontaneamente no relato, embora possam afetar vínculo, autoestima e adesão silenciosa. Em sessão, o tema às vezes aparece deslocado para conflitos conjugais, evitação de intimidade ou sensação de inadequação. A discriminação importante é entre efeito associado ao tratamento, retraimento afetivo do episódio depressivo, tensão relacional prévia ou mudança mais ampla na dinâmica do casal.

Adesão e descontinuação: A paroxetina merece atenção especial à regularidade de uso, porque esquecimentos, interrupção por conta própria ou tomada errática podem ser seguidos em poucos dias por tontura, mal-estar, irritabilidade, sensação de choque no corpo, choro fácil ou estranheza subjetiva. Na sessão, isso pode parecer recaída abrupta, crise ansiosa sem gatilho claro ou desorganização emocional inesperada. Quando o padrão temporal é muito súbito e coincide com falhas de uso, vale registrar essa hipótese antes de concluir que houve piora primária do transtorno.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma melhora inicial pode se confundir com aceleração patológica do humor. O terapeuta pode notar redução importante da necessidade de sono, fala pressionada, aumento de planos, irritabilidade incomum, expansividade ou autoconfiança pouco habitual para a linha de base. O desafio é distinguir alívio legítimo após semanas de sofrimento de uma mudança qualitativa do estado mental que pede comunicação mais rápida com o médico assistente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A paroxetina é um antidepressivo da classe dos ISRSs, encontrado com frequência em pacientes em tratamento de depressão, transtornos de ansiedade, pânico, fobia social, TOC e TEPT. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta pode acompanhar oscilação entre discreta ativação, náusea, piora subjetiva da ansiedade ou sonolência, antes de mudanças mais consistentes no humor e na ansiedade, que costumam ficar mais legíveis entre 4 e 8 semanas. Nesta substância, vale atenção especial a embotamento afetivo, impacto sexual e sinais de uso irregular, porque interrupções de poucos dias podem coincidir com mal-estar, tontura, irritabilidade e sensação de “estranheza”, facilmente confundidos com recaída ou crise do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Essa piora da ansiedade apareceu como continuação do seu padrão habitual ou começou de um jeito mais abrupto depois de alguma mudança na rotina do remédio? , Quando você diz que está melhor, sente também mais interesse, prazer e presença emocional, ou está mais sem sofrimento porém meio anestesiado por dentro? , Nos dias em que ficou mais estranho ou irritado, houve esquecimento, interrupção ou tomada irregular do remédio perto desse período? , Essa dificuldade sexual apareceu junto com melhora ou piora do humor, ou parece mais localizada na resposta do corpo apesar de o vínculo e o desejo pelo parceiro estarem preservados? , Você está dormindo menos porque está ansioso e cansado, ou dormindo menos sem sentir falta de sono, com mais energia, pressa ou ideias do que o seu habitual? , Esse cansaço parece vir com tristeza, desesperança e peso para fazer as coisas, ou é mais uma sensação de sonolência e lentidão com o humor relativamente estável?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente relata interrupções de poucos dias
- uso errático ou vontade de abandonar silenciosamente por efeitos incômodos
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar adesão e evitar leituras equivocadas de recaída
- Quando surgem queixas sexuais persistentes com impacto em vínculo
- autoestima ou risco de abandono do tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente pela relevância clínica para adesão
- Quando
- após 6 a 8 semanas de uso regular
- a sessão segue mostrando pouca mudança em humor
- ansiedade ou funcionalidade
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisão do quadro e da resposta clínica
- Quando aparece embotamento afetivo importante
- com redução do sofrimento mas também perda de interesse
- espontaneidade e acesso emocional
- pode valer comunicar o médico assistente para qualificar o impacto funcional

Amarelo: alinhar em breve

- Quando a melhora vem acompanhada de redução importante do sono
- aceleração
- irritabilidade ou expansividade fora da linha de base
- pode valer alinhar com o psiquiatra pela possibilidade de mudança de polaridade
- Quando o paciente descreve mal-estar abrupto
- tontura
- irritabilidade e sensação corporal estranha após falhas de uso
- pode valer comunicar o médico assistente para contextualizar a hipótese de descontinuação

Vermelho: tratar como urgência

- A sessão revela ideação suicida com intenção
- plano
- preparo ou incapacidade de combinar segurança mínima no curto prazo.: Interrompa o manejo habitual da sessão e ative hoje os recursos de crise: psiquiatra
- familiares ou rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente aparece muito confuso
- intensamente agitado
- suando
- tremendo e com piora rápida do estado geral durante ou pouco antes da sessão.: Considere urgência clínica
- não conduza como mera ansiedade e acione avaliação médica imediata ou emergência conforme a gravidade

Frase clínica

Na terapia, o foco com paroxetina costuma ser separar melhora real de embotamento, detectar uso irregular e observar sexualidade e virada de humor.

111 CLORIDRATO DE PAROXETINA HEMI-HIDRATADO

Substância: Cloridrato de Paroxetina Hemi-Hidratado.

Nomes Comerciais: Pondera Xr, Sincro Xr, Cloridrato de Paroxetina, Roxetin Xr, Paxtrat, Depaxan, Cloridrato de Paroxetina (Port 344/98 Lista C1), Moratus

Uso comum

- A paroxetina é um antidepressivo da classe dos ISRSs, encontrado com frequência em quadros de depressão, transtornos de ansiedade, pânico, ansiedade social, TOC e TEPT. Na terapia, costuma ser útil acompanhar com mais atenção as primeiras 2 a 4 semanas, quando podem surgir ativação ansiosa, desconfortos que afetam adesão ou, em alguns pacientes, aumento de inquietação e piora subjetiva antes de benefício mais nítido. Ganho terapêutico costuma ficar mais claro ao longo de 4 a 8 semanas. Também vale manter no radar adesão irregular e interrupções, porque a paroxetina está entre os antidepressivos em que sintomas de descontinuação podem aparecer em poucos dias e confundir a leitura clínica da sessão.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais tensos, inquietos ou com sensação de piora da ansiedade, o que pode ser lido apressadamente como agravamento do quadro de base ou efeito de eventos externos. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais acelerada, menor tolerância à espera, hipervigilância corporal ou medo de que “o remédio não esteja fazendo bem”. A discriminação clínica costuma depender da linha de base: se a intensificação surgiu logo após o início e sem mudança proporcional no contexto de vida, vale registrar como hipótese observacional, sem concluir causalidade.

Embotamento afetivo: Com a redução de sintomas mais agudos, parte dos pacientes descreve menos sofrimento, mas também menos acesso afetivo, menor espontaneidade ou sensação de estar “anestesiado”. Em sessão, isso pode se confundir com melhora real do humor, defesa dissociativa, retraimento depressivo residual ou acomodação relacional. O ponto não é tomar a redução da intensidade emocional como ganho automático, mas observar se houve ampliação de repertório e elaboração ou apenas achatamento da experiência subjetiva.

Sexualidade: A paroxetina pode entrar silenciosamente na clínica pela via da sexualidade: queda de desejo, dificuldade de excitação ou atraso importante para chegar ao orgasmo podem alterar autoestima, vínculo conjugal e adesão. Como muitos pacientes não trazem isso espontaneamente, o terapeuta pode notar esquiva do tema, irritação no casal ou explicações exclusivamente relacionais para uma mudança temporalmente nova. Também aqui a leitura pede cautela, porque depressão, ansiedade de desempenho, conflitos afetivos e outras medicações podem produzir quadro semelhante.

Sedação e energia: Alguns pacientes ficam mais sonolentos, lentificados ou com sensação de peso ao longo do dia, enquanto outros relatam melhora do sono noturno e, secundariamente, mais estabilidade. Na sessão, a diferença entre sedação medicamentosa, fadiga depressiva e exaustão por rotina costuma aparecer no ritmo da fala, na capacidade de sustentar atenção e na variação entre dias. Se a lentificação surge sem rebaixamento afetivo proporcional, especialmente após início ou retomada irregular, vale considerar essa hipótese na formulação clínica.

Adesão e descontinuação: A adesão irregular é um ponto central com paroxetina porque pequenas interrupções podem ser seguidas de mal-estar, tontura, sensação de estranheza corporal, irritabilidade, piora abrupta da ansiedade ou labilidade que o paciente pode entender como recaída. Em sessão, o quadro às vezes parece uma desorganização súbita “sem motivo”, mas a cronologia ajuda: sintomas que aparecem em poucos dias após esquecimento, falta do medicamento ou interrupção por conta própria pedem outra leitura. Isso é clinicamente relevante porque efeitos incômodos e impacto sexual frequentemente motivam abandono silencioso.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma melhora inicial pode vir acompanhada de redução importante da necessidade de sono, aceleração, expansividade, irritabilidade ou aumento de impulsividade, o que não equivale simplesmente a “estar melhor”. Na sessão, esse quadro pode ser confundido com alívio depressivo legítimo, retomada de projetos ou entusiasmo após um período difícil. O diferencial costuma estar na mudança de baseline, na perda de freio, no caráter pouco usual para a história do paciente e no

descompasso entre energia aumentada e capacidade de julgamento."

O que observar em sessão

- **Ansiedade inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais tensos, inquietos ou com sensação de piora da ansiedade, o que pode ser lido apressadamente como agravamento do quadro de base ou efeito de eventos externos. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais acelerada, menor tolerância à espera, hipervigilância corporal ou medo de que “o remédio não esteja fazendo bem”. A discriminação clínica costuma depender da linha de base: se a intensificação surgiu logo após o início e sem mudança proporcional no contexto de vida, vale registrar como hipótese observacional, sem concluir causalidade.

Embotamento afetivo: Com a redução de sintomas mais agudos, parte dos pacientes descreve menos sofrimento, mas também menos acesso afetivo, menor espontaneidade ou sensação de estar “anestesiado”. Em sessão, isso pode se confundir com melhora real do humor, defesa dissociativa, retraimento depressivo residual ou acomodação relacional. O ponto não é tomar a redução da intensidade emocional como ganho automático, mas observar se houve ampliação de repertório e elaboração ou apenas achatamento da experiência subjetiva.

Sexualidade: A paroxetina pode entrar silenciosamente na clínica pela via da sexualidade: queda de desejo, dificuldade de excitação ou atraso importante para chegar ao orgasmo podem alterar autoestima, vínculo conjugal e adesão. Como muitos pacientes não trazem isso espontaneamente, o terapeuta pode notar esquiva do tema, irritação no casal ou explicações exclusivamente relacionais para uma mudança temporalmente nova. Também aqui a leitura pede cautela, porque depressão, ansiedade de desempenho, conflitos afetivos e outras medicações podem produzir quadro semelhante.

Sedação e energia: Alguns pacientes ficam mais sonolentos, lentificados ou com sensação de peso ao longo do dia, enquanto outros relatam melhora do sono noturno e, secundariamente, mais estabilidade. Na sessão, a diferença entre sedação medicamentosa, fadiga depressiva e exaustão por rotina costuma aparecer no ritmo da fala, na capacidade de sustentar atenção e na variação entre dias. Se a lentificação surge sem rebaixamento afetivo proporcional, especialmente após início ou retomada irregular, vale considerar essa hipótese na formulação clínica.

Adesão e descontinuação: A adesão irregular é um ponto central com paroxetina porque pequenas interrupções podem ser seguidas de mal-estar, tontura, sensação de estranheza corporal, irritabilidade, piora abrupta da ansiedade ou labilidade que o paciente pode entender como recaída. Em sessão, o quadro às vezes parece uma desorganização súbita “sem motivo”, mas a cronologia ajuda: sintomas que aparecem em poucos dias após esquecimento, falta do medicamento ou interrupção por conta própria pedem outra leitura. Isso é clinicamente relevante porque efeitos incômodos e impacto sexual frequentemente motivam abandono silencioso.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma melhora inicial pode vir acompanhada de redução importante da necessidade de sono, aceleração, expansividade, irritabilidade ou aumento de impulsividade, o que não equivale simplesmente a “estar melhor”. Na sessão, esse quadro pode ser confundido com alívio depressivo legítimo, retomada de projetos ou entusiasmo após um período difícil. O diferencial costuma estar na mudança de baseline, na perda de freio, no caráter pouco usual para a história do paciente e no

descompasso entre energia aumentada e capacidade de julgamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A paroxetina é um antidepressivo da classe dos ISRSs, encontrado com frequência em quadros de depressão, transtornos de ansiedade, pânico, ansiedade social, TOC e TEPT. Na terapia, costuma ser útil acompanhar com mais atenção as primeiras 2 a 4 semanas, quando podem surgir ativação ansiosa, desconfortos que afetam adesão ou, em alguns pacientes, aumento de inquietação e piora subjetiva antes de benefício mais nítido. Ganho terapêutico costuma ficar mais claro ao longo de 4 a 8 semanas. Também vale manter no radar adesão irregular e interrupções, porque a paroxetina está entre os antidepressivos em que sintomas de descontinuação podem aparecer em poucos dias e confundir a leitura clínica da sessão.

Perguntas úteis

- "Essa piora que você percebeu começou junto de alguma mudança concreta na sua rotina ou apareceu mais de repente, sem um gatilho claro, nos dias seguintes ao início ou a falhas no uso? , Quando você diz que está melhor, você se sente mais vivo e com mais acesso ao que sente, ou mais indiferente e menos tocado pelas coisas? , Na sua vida sexual, a mudança parece mais ligada ao vínculo e ao desejo pelo parceiro, ou seu corpo e sua resposta sexual mudaram mesmo quando o interesse afetivo continua presente? , Esse cansaço vem com tristeza, desesperança e peso depressivo, ou é mais uma sonolência e lentidão corporal com a cabeça menos deprimida do que antes? , Nos dias em que você esqueceu, atrasou ou ficou sem tomar, apareceu alguma mudança rápida no corpo ou no humor diferente do padrão habitual da sua semana? , Essa energia maior veio junto de menos necessidade de sono, mais impulsividade ou sensação de estar acelerado além do seu normal, ou parece uma retomada gradual do seu funcionamento habitual?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente relata interrupções
- esquecimentos frequentes ou retomadas irregulares acompanhadas de piora abrupta do humor
- ansiedade ou sensações corporais estranhas
- pode valer alinhar com o psiquiatra para esclarecer se há impacto clínico da adesão irregular
- Quando surgem dificuldades sexuais novas e persistentes que começam a afetar vínculo
- autoestima ou motivação para seguir o tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente porque esse é um motivo comum de abandono silencioso
- Quando a sessão mostra embotamento afetivo importante
- com redução do sofrimento mas também perda de acesso emocional e empobrecimento da experiência subjetiva
- pode valer alinhar com o psiquiatra para qualificar o balanço clínico do tratamento
- Quando aparece aumento de energia com menos sono

Amarelo: alinhar em breve

- aceleração
- irritabilidade ou impulsividade fora do padrão do paciente
- pode valer contato com o psiquiatra para discutir possível mudança de estado de humor
- Quando
- após 6 a 8 semanas de uso aparentemente regular
- não se observa melhora minimamente consistente do quadro que motivou o tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente para atualização da evolução clínica

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a falar em morte
- desesperança extrema
- impulso de se ferir ou planejamento suicida com aumento de agitação.: Avalie risco imediatamente
- acione o psiquiatra no mesmo dia e mobilize rede de apoio e emergência quando necessário
- Surge mudança nítida do baseline com fala muito acelerada
- pouca necessidade de sono
- expansividade ou irritabilidade marcante e aumento de impulsividade.: Contate o psiquiatra no mesmo dia e reavalie segurança
- julgamento e exposição a riscos até nova orientação médica

Frase clínica

Com paroxetina, o foco clínico costuma estar em ansiedade inicial, embotamento afetivo, sexualidade e descontinuação que imita recaída.

112 CLORIDRATO DE SERTRALINA

Substância: Cloridrato de Sertralina.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Sertralina, Assert, Afetus, Zoloft, Serenata, Tolrest, Ralzin, Dieloft

Uso comum

- A sertralina é um antidepressivo de uso frequente em depressão, transtornos de ansiedade, pânico, TOC e quadros relacionados. No consultório, as primeiras 1 a 2 semanas costumam ser a janela em que mais aparecem ativação, desconforto gastrointestinal, piora subjetiva da ansiedade, alterações de sono ou sensação de estranhamento afetivo; benefícios mais consistentes tendem a ficar mais claros ao longo de 4 a 8 semanas. Também vale acompanhar mudanças na sexualidade e sinais de uso irregular, porque interrupções de alguns dias podem confundir a leitura clínica com recaída ou instabilidade do quadro. O ponto central na sessão é diferenciar melhora real de embotamento, ansiedade basal de ativação inicial e recaída de descontinuação.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade inicial:** No início do uso, alguns pacientes chegam mais agitados, inquietos ou com sensação de piora da ansiedade, o que pode ser vivido como prova de que “o remédio fez mal” ou de que o quadro está desorganizando. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais tensa, menor tolerância à espera, urgência por alívio e dificuldade de discriminar medo habitual de um estado corporal novo. A leitura se confunde facilmente com estressores recentes, expectativa catastrófica diante do tratamento ou oscilação própria do transtorno de base, especialmente quando a adesão ainda é irregular.

Humor e embotamento: Com a evolução das semanas, pode haver redução do sofrimento depressivo e da reatividade emocional, mas parte dos pacientes descreve isso como distanciamento afetivo, menor acesso ao choro ou sensação de estar “mais plano”. Em sessão, interessa observar se houve ampliação de funcionamento e elaboração ou apenas diminuição da intensidade afetiva sem ganho subjetivo de vitalidade. Esse ponto pode se confundir tanto com melhora legítima do humor quanto com defesa psíquica, exaustão crônica ou adaptação a um período menos estressante da vida.

Sono e energia: A sertralina pode coincidir com mais sonolência, fadiga ou, em outros casos, com maior alerta e dificuldade para desacelerar, sobretudo nas primeiras semanas. O terapeuta pode notar bocejos, lentificação, queda de concentração ou, no polo oposto, aceleração e impaciência que não estavam na baseline da sessão. Como depressão, ansiedade, privação de sono, cafeína, outras medicações e rotina desorganizada produzem apresentações semelhantes, a utilidade clínica está em mapear temporalidade e padrão de oscilação.

Sexualidade: Mudanças em desejo, excitação e orgasmo têm alto valor clínico porque frequentemente aparecem tarde, são pouco espontaneamente verbalizadas e podem levar a abandono silencioso. Na sessão, o paciente pode falar em perda de interesse, frustração, evitação de intimidade ou conflito conjugal sem ligar isso ao início do tratamento. A diferenciação importante é entre efeito associado ao uso, piora depressiva, tensão relacional prévia ou retraimento afetivo mais amplo.

Adesão e descontinuação: Esquecimentos, pausas de alguns dias, retomadas irregulares ou interrupção por conta própria podem produzir oscilação clínica difícil de ler, especialmente quando o paciente relata que “uma semana estava melhor e na outra desandou”. Em sessão, isso às vezes aparece menos como informação direta e mais como narrativa confusa, vergonha de admitir uso inconsistente ou atribuição global ao medicamento de tudo o que mudou. Quando há uso irregular, ansiedade, irritabilidade, mal-estar e sensação de instabilidade podem ser confundidos com recaída do quadro de base.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma melhora inicial pode vir acompanhada de redução excessiva da necessidade de sono, aceleração, expansividade ou irritabilidade fora do padrão habitual. Na sessão, isso pode ser confundido com alívio depressivo, retomada de produtividade ou “volta ao normal”, sobretudo se o paciente valoriza o ganho de energia e minimiza prejuízos. O ponto clínico é observar mudança qualitativa do estado mental, e não apenas intensidade de melhora."

O que observar em sessão

- **Ansiedade inicial:** No início do uso, alguns pacientes chegam mais agitados, inquietos ou com sensação de piora da ansiedade, o que pode ser vivido como prova de que “o remédio fez mal” ou de que o quadro está desorganizando. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais tensa, menor tolerância à espera, urgência por alívio e dificuldade de discriminar medo habitual de um estado corporal novo. A leitura se confunde facilmente com estressores recentes, expectativa catastrófica diante do tratamento ou oscilação própria do transtorno de base, especialmente quando a adesão ainda é irregular.

Humor e embotamento: Com a evolução das semanas, pode haver redução do sofrimento depressivo e da reatividade emocional, mas parte dos pacientes descreve isso como distanciamento afetivo, menor acesso ao choro ou sensação de estar “mais plano”. Em sessão, interessa observar se houve ampliação de funcionamento e elaboração ou apenas diminuição da intensidade afetiva sem ganho subjetivo de vitalidade. Esse ponto pode se confundir tanto com melhora legítima do humor quanto com defesa psíquica, exaustão crônica ou adaptação a um período menos estressante da vida.

Sono e energia: A sertralina pode coincidir com mais sonolência, fadiga ou, em outros casos, com maior alerta e dificuldade para desacelerar, sobretudo nas primeiras semanas. O terapeuta pode notar bocejos, lentificação, queda de concentração ou, no polo oposto, aceleração e impaciência que não estavam na baseline da sessão. Como depressão, ansiedade, privação de sono, cafeína, outras medicações e rotina desorganizada produzem apresentações semelhantes, a utilidade clínica está em mapear temporalidade e padrão de oscilação.

Sexualidade: Mudanças em desejo, excitação e orgasmo têm alto valor clínico porque frequentemente aparecem tarde, são pouco espontaneamente verbalizadas e podem levar a abandono silencioso. Na sessão, o paciente pode falar em perda de interesse, frustração, evitação de intimidade ou conflito conjugal sem ligar isso ao início do tratamento. A diferenciação importante é entre efeito associado ao uso, piora depressiva, tensão relacional prévia ou retraimento afetivo mais amplo.

Adesão e descontinuação: Esquecimentos, pausas de alguns dias, retomadas irregulares ou interrupção por conta própria podem produzir oscilação clínica difícil de ler, especialmente quando o paciente relata que “uma semana estava melhor e na outra desandou”. Em sessão, isso às vezes aparece menos como informação direta e mais como narrativa confusa, vergonha de admitir uso inconsistente ou atribuição global ao medicamento de tudo o que mudou. Quando há uso irregular, ansiedade, irritabilidade, mal-estar e sensação de instabilidade podem ser confundidos com recaída do quadro de base.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma melhora inicial pode vir acompanhada de redução excessiva da necessidade de sono, aceleração, expansividade ou irritabilidade fora do padrão habitual. Na sessão, isso pode ser confundido com alívio depressivo, retomada de produtividade ou “volta ao normal”, sobretudo se o paciente valoriza o ganho de energia e minimiza prejuízos. O ponto clínico é observar mudança qualitativa do estado mental, e não apenas intensidade de melhora.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A sertralina é um antidepressivo de uso frequente em depressão, transtornos de ansiedade, pânico, TOC e quadros relacionados. No consultório, as primeiras 1 a 2 semanas costumam ser a janela em que mais aparecem ativação, desconforto gastrointestinal, piora subjetiva da ansiedade, alterações de sono ou sensação de estranhamento afetivo; benefícios mais consistentes tendem a ficar mais claros ao longo de 4 a 8 semanas. Também vale acompanhar mudanças na sexualidade e sinais de uso irregular, porque interrupções de alguns dias podem confundir a leitura clínica com recaída ou instabilidade do quadro. O ponto central na sessão é diferenciar melhora real de embotamento, ansiedade basal de ativação inicial e recaída de descontinuação.

Perguntas úteis

- "Quando essa piora da ansiedade apareceu, ela veio como um medo parecido com o seu padrão habitual ou como uma inquietação mais corporal e diferente do que você costuma sentir? , Nessas últimas semanas, você se sente melhor no sentido de estar mais disponível para a vida, ou mais amortecido, como se sofresse menos mas também sentisse menos? , Essa mudança no sono e na energia parece acompanhar o humor ao longo do dia ou surgiu como algo novo depois do início do tratamento, sem combinar com o seu padrão anterior? , Na sua vida sexual, o que mudou mais: o interesse pelo encontro, a resposta do corpo ou a capacidade de chegar ao orgasmo? , Quando você diz que houve uma piora repentina, isso aconteceu em um período de uso contínuo ou perto de dias em que você esqueceu, interrompeu ou retomou a medicação? , Esse aumento de energia veio com mais clareza e organização, ou com menos necessidade de sono, mais impulsividade, irritação ou sensação de estar acelerado demais para o seu normal?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve piora importante da ansiedade
- agitação ou insônia logo nas primeiras semanas a ponto de comprometer adesão ou funcionamento
- pode valer alinhar com o psiquiatra para contextualizar a intensidade e o impacto clínico
- Quando surgem sinais de embotamento afetivo persistente
- com redução do sofrimento mas também perda de envolvimento
- iniciativa ou acesso emocional
- pode valer comunicar o médico para diferenciar resposta parcial de tolerabilidade ruim
- Quando alterações sexuais passam a afetar vínculo conjugal
- autoestima ou motivação para manter o tratamento
- pode valer alinhar com o psiquiatra porque esse é um motivo frequente de abandono silencioso
- Quando o paciente revela uso irregular
- pausas de alguns dias ou interrupção por conta própria
- pode valer comunicar o médico para evitar que oscilações subsequentes sejam lidas apenas como recaída do quadro

Amarelo: alinhar em breve

- Quando aparece aceleração incomum
- redução importante da necessidade de sono
- expansividade ou irritabilidade fora da baseline
- pode valer contato com o psiquiatra para avaliar possível mudança qualitativa do humor
- Quando
- após 6 a 8 semanas de uso aparentemente regular
- não se observa melhora clínica minimamente consistente
- pode valer alinhar com o médico para compartilhar a evolução acompanhada em sessão

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a falar em vontade de morrer
- planejamento
- impulso de se ferir ou sensação de que pode agir.: Avalie risco imediatamente
- acione psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhe para emergência quando houver risco iminente
- Surge mudança abrupta do estado mental com fala muito acelerada
- pouca necessidade de sono
- aumento de impulsividade
- grandiosidade ou irritabilidade marcante fora do padrão habitual.: Contate o psiquiatra no mesmo dia e organize contenção clínica e apoio próximo
- considerando avaliação de urgência se houver prejuízo importante de juízo crítico ou risco

Frase clínica

Na terapia, o foco com sertralina é separar melhora real de embotamento, ativação inicial de ansiedade basal e recaída de uso irregular.

113 HIDROBROMETO DE CITALOPRAM (PORT. 344/98 LISTA C 1)

Substância: Hidrobrometo de Citalopram (Port. 344/98 Lista C 1).

Nomes Comerciais: Citalopram

Uso comum

- O citalopram é um antidepressivo da classe dos ISRSs, encontrado com frequência em quadros depressivos e ansiosos acompanhados em psicoterapia. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta pode notar oscilação entre discreta ativação, desconfortos iniciais e pouca mudança no sofrimento central; entre 3 e 6 semanas, costuma ficar mais nítido se há redução de ansiedade, melhora do humor ou apenas tolerância parcial. Em interrupções abruptas ou uso irregular por alguns dias, podem surgir mudanças rápidas no estado subjetivo que confundem recaída. O ponto central na sessão é distinguir melhora clínica de embotamento, ativação inicial de ansiedade basal e efeito do remédio de adesão inconsistente ou eventos de vida recentes.

O paciente pode relatar

- **"Humor e afeto:** Ao longo das semanas, alguns pacientes descrevem menos choro, menor desesperança e mais capacidade de atravessar o dia, enquanto outros parecem apenas menos reativos, com acesso afetivo achatado e elaboração mais pobre. Na sessão, vale observar se a redução do sofrimento vem acompanhada de retomada de interesse, flexibilidade psíquica e maior contato com a experiência, ou se há um tom de indiferença ego-distônica. Essa diferença pode se confundir com remissão parcial da depressão, defesa diante de eventos recentes ou adaptação ao próprio quadro.

Ansiedade inicial: No começo do uso, pode aparecer inquietação, aumento de tensão interna, sensação de estar mais acelerado por dentro ou piora transitória da ansiedade, especialmente antes de qualquer benefício mais claro. Em sessão, isso às vezes surge como impaciência corporal, dificuldade de permanecer no tema ou relato de desconforto sem o padrão cognitivo habitual das crises ansiosas do paciente. Também pode ser lido, de forma apressada, como agravamento do quadro de base, estresse ambiental ou consumo de caféina e outras substâncias.

Sono e energia: Mudanças no sono e na energia costumam ser clinicamente úteis porque tanto a melhora do humor quanto os efeitos iniciais podem alterar o padrão da sessão. Alguns pacientes ficam mais sonolentos, lentificados ou menos disponíveis cognitivamente; outros relatam sono mais fragmentado ou sensação de cansaço sem piora proporcional do humor. Isso pode se confundir com depressão ainda ativa, privação de sono por rotina, outras medicações sedativas ou ansiedade noturna.

Sexualidade: Redução de desejo, dificuldade de excitação ou atraso para atingir orgasmo podem aparecer mesmo quando o paciente melhora em outros domínios e, por vergonha, às vezes ficam fora do relato espontâneo. Na sessão, o tema pode emergir indiretamente como afastamento do parceiro, queda de autoestima, irritação no vínculo ou abandono silencioso do tratamento. Sem exploração cuidadosa, é fácil atribuir tudo a conflito conjugal, depressão residual ou desinteresse afetivo que já existia antes.

Adesão e descontinuação: O citalopram pode gerar um padrão clínico em que o paciente alterna dias de uso, esquece tomadas em fins de semana ou interrompe por conta própria quando se sente melhor ou incomodado com efeitos subjetivos. Em sessão, isso aparece como oscilação pouco explicável entre encontros, piora súbita após alguns dias, ou narrativa inconsistente sobre quando começou a mudança. Sem perguntar de modo direto e simples, o terapeuta pode ler como recaída, resistência ao tratamento ou instabilidade emocional primária.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma melhora que parece rápida demais pode vir acompanhada de redução importante da necessidade de sono, expansividade, irritabilidade nova, aumento de impulsividade ou sensação de clareza excepcional. Na sessão, isso pode ser confundido com alívio legítimo após semanas difíceis, sobretudo se o paciente chega mais falante, confiante e produtivo. O discriminador clínico costuma estar menos no bom humor em si e mais na mudança de ritmo, juízo e padrão de funcionamento."

O que observar em sessão

- **Humor e afeto:** Ao longo das semanas, alguns pacientes descrevem menos choro, menor desesperança e mais capacidade de atravessar o dia, enquanto outros parecem apenas menos reativos, com acesso afetivo achatado e elaboração mais pobre. Na sessão, vale observar se a redução do sofrimento vem acompanhada de retomada de interesse, flexibilidade psíquica e maior contato com a experiência, ou se há um tom de indiferença ego-distônica. Essa diferença pode se confundir com remissão parcial da depressão, defesa diante de eventos recentes ou adaptação ao próprio quadro.

Ansiedade inicial: No começo do uso, pode aparecer inquietação, aumento de tensão interna, sensação de estar mais acelerado por dentro ou piora transitória da ansiedade, especialmente antes de qualquer benefício mais claro. Em sessão, isso às vezes surge como impaciência corporal, dificuldade de permanecer no tema ou relato de desconforto sem o padrão cognitivo habitual das crises ansiosas do paciente. Também pode ser lido, de forma apressada, como agravamento do quadro de base, estresse ambiental ou consumo de cafeína e outras substâncias.

Sono e energia: Mudanças no sono e na energia costumam ser clinicamente úteis porque tanto a melhora do humor quanto os efeitos iniciais podem alterar o padrão da sessão. Alguns pacientes ficam mais sonolentos, lentificados ou menos disponíveis cognitivamente; outros relatam sono mais fragmentado ou sensação de cansaço sem piora proporcional do humor. Isso pode se confundir com depressão ainda ativa, privação de sono por rotina, outras medicações sedativas ou ansiedade noturna.

Sexualidade: Redução de desejo, dificuldade de excitação ou atraso para atingir orgasmo podem aparecer mesmo quando o paciente melhora em outros domínios e, por vergonha, às vezes ficam fora do relato espontâneo. Na sessão, o tema pode emergir indiretamente como afastamento do parceiro, queda de autoestima, irritação no vínculo ou abandono silencioso do tratamento. Sem exploração cuidadosa, é fácil atribuir tudo a conflito conjugal, depressão residual ou desinteresse afetivo que já existia antes.

Adesão e descontinuação: O citalopram pode gerar um padrão clínico em que o paciente alterna dias de uso, esquece tomadas em fins de semana ou interrompe por conta própria quando se sente melhor ou incomodado com efeitos subjetivos. Em sessão, isso aparece como oscilação pouco explicável entre encontros, piora súbita após alguns dias, ou narrativa inconsistente sobre quando começou a mudança. Sem perguntar de modo direto e simples, o terapeuta pode ler como recaída, resistência ao tratamento ou instabilidade emocional primária.

Virada de humor: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar não reconhecida, uma melhora que parece rápida demais pode vir acompanhada de redução importante da necessidade de sono, expansividade, irritabilidade nova, aumento de impulsividade ou sensação de clareza excepcional. Na sessão, isso pode ser confundido com alívio legítimo após semanas difíceis, sobretudo se o paciente chega mais falante, confiante e produtivo. O discriminador clínico costuma estar menos no bom humor em si e mais na mudança de ritmo, juízo e padrão de funcionamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O citalopram é um antidepressivo da classe dos ISRSs, encontrado com frequência em quadros depressivos e ansiosos acompanhados em psicoterapia. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta pode notar oscilação entre discreta ativação, desconfortos iniciais e pouca mudança no sofrimento central; entre 3 e 6 semanas, costuma ficar mais nítido se há redução de ansiedade, melhora do humor ou apenas tolerância parcial. Em interrupções abruptas ou uso irregular por alguns dias, podem surgir mudanças rápidas no estado subjetivo que confundem recaída. O ponto central na sessão é distinguir melhora clínica de embotamento, ativação inicial de ansiedade basal e efeito do remédio de adesão inconsistente ou eventos de vida recentes.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está melhor, essa melhora vem com mais interesse e presença na vida ou com uma sensação de estar meio indiferente ao que antes importava? , Essa ansiedade que apareceu se parece com a sua ansiedade de costume, com pensamentos e gatilhos conhecidos, ou é mais uma inquietação corporal nova, sem o mesmo enredo? , Nos dias em que você se sente pior ou estranho, isso aconteceu de forma gradual ou depois de algum período em que você pulou, esqueceu ou interrompeu o remédio? , A mudança no desejo ou na resposta sexual apareceu junto com conflitos na relação ou surgiu mesmo quando o vínculo estava parecido com antes? , Esse aumento de energia veio com mais clareza e organização ou junto com menos sono, mais impulsividade e uma sensação de estar acelerado além do seu habitual?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve piora importante da ansiedade
- agitação ou inquietação nas primeiras semanas a ponto de comprometer rotina
- vínculo ou permanência no tratamento
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar a evolução clínica
- Quando surgem queixas sexuais persistentes que começam a afetar vínculo amoroso
- autoestima ou adesão silenciosa
- pode valer comunicar o médico assistente para que esse fator entre na leitura do caso
- Quando há uso irregular
- interrupções por conta própria ou oscilação clínica que coincide com esquecimentos frequentes
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar adesão inconsistente de resposta insuficiente
- Quando a melhora vem acompanhada de menos sono
- aceleração
- irritabilidade nova ou condutas mais impulsivas
- pode valer contato com o psiquiatra para avaliar possível mudança de polaridade
- Quando
- após cerca de 4 a 6 semanas de uso aparentemente regular

Amarelo: alinhar em breve

- não se observa mudança clínica relevante no humor ou na ansiedade
- pode valer comunicar o médico assistente para compor a avaliação de resposta

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a falar em morte
- desesperança mais intensa ou intenção de se ferir de modo novo ou claramente agravado.: Avaliar risco imediatamente
- acionar psiquiatra no mesmo dia e mobilizar rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente chega muito mais acelerado que sua linha de base
- dormindo pouco sem cansaço
- com fala pressionada
- grandiosidade ou impulsos que sugerem perda de juízo habitual.: Tratar como mudança aguda relevante
- contatar o psiquiatra no mesmo dia e avaliar necessidade de suporte urgente com rede de apoio

Frase clínica

No citalopram, o foco clínico é separar melhora real de embotamento, ativação inicial de ansiedade basal e recaída de adesão irregular.

114 MALEATO DE FLUVOXAMINA

Substância: Maleato de Fluvoxamina.

Nomes Comerciais: Maleato de Fluvoxamina, Afluv, Fluviq, Luvox, Revoc, Semtri

Uso comum

- A fluvoxamina é um antidepressivo ISRS que costuma aparecer no consultório sobretudo em pacientes com TOC, depressão e quadros ansiosos. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto piora subjetiva de ansiedade, desconforto gastrointestinal, alteração do sono e oscilação de tolerabilidade, que podem interferir na adesão antes de qualquer benefício percebido. Em depressão e ansiedade, alguma mudança clínica costuma ser buscada ao longo de 2 a 6 semanas; em sintomas obsessivo-compulsivos, a leitura costuma exigir mais tempo, frequentemente entre 6 e 12 semanas. O ponto central na sessão é diferenciar ativação inicial, melhora parcial, embotamento, adesão irregular e evolução do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais tensos, inquietos ou com sensação de piora, o que pode ser vivido como sinal de que “não está fazendo bem” e favorecer abandono silencioso. Na sessão, isso pode aparecer como maior urgência na fala, dificuldade de permanecer com o tema ou aumento da vigilância corporal. Vale não tomar automaticamente esse movimento como agravamento do transtorno de base: a proximidade temporal com o início, a flutuação ao longo dos dias e a coexistência com outros desconfortos iniciais ajudam a discriminar.

TOC e ruminação: Quando a fluvoxamina entra em quadros obsessivo-compulsivos, a mudança mais útil para o terapeuta nem sempre é redução imediata do conteúdo obsessivo, mas alteração no tempo gasto, na urgência dos rituais e na capacidade de adiar respostas compulsivas. Em sessão, o paciente pode seguir trazendo os mesmos temas, porém com um pouco mais de distância reflexiva ou menor fusão com a urgência. Isso pode se confundir com oscilação natural do TOC, efeito de intervenções psicoterápicas ou variações de estresse ambiental, por isso convém observar tendência ao longo de semanas, não apenas uma sessão isolada.

Sono e ativação: O padrão de sono pode mudar para mais insônia, sono fragmentado ou, em alguns casos, mais sonolência e lentificação subjetiva. No consultório, isso aparece como fadiga, bocejos, dificuldade de concentração ou, no polo oposto, aceleração e menor tolerância ao silêncio. A leitura pode se embaralhar com depressão, rotina desorganizada, uso de cafeína, outras medicações e ansiedade antecipatória; por isso ajuda mapear se a alteração surgiu junto com o início do medicamento e se varia de forma diferente do humor.

Embotamento afetivo: Depois das primeiras semanas, parte dos pacientes descreve menos sofrimento, mas também menos acesso afetivo, como se estivessem “mais estáveis” e ao mesmo tempo menos tocados. Na sessão, isso pode ser percebido como narrativa mais plana, menor ressonância emocional e redução da reatividade, sem necessariamente corresponder a elaboração maior. O ponto clínico é diferenciar melhora real da depressão ou da ansiedade de um achatamento subjetivo que o paciente vive como perda de vitalidade, porque essa diferença muda a leitura da adesão e do vínculo com o tratamento.

Sexualidade: Dificuldades de desejo, excitação ou orgasmo podem surgir e muitas vezes ficam fora do relato espontâneo, embora tenham peso importante na autoestima, na vida conjugal e na continuidade do uso. Em sessão, o tema pode aparecer deslocado como afastamento do parceiro, irritação relacional ou sensação de estranhamento com o próprio corpo. Sem investigação cuidadosa, isso pode ser lido apenas como conflito de casal, piora depressiva ou desinteresse afetivo, quando às vezes o paciente está tentando acomodar uma mudança corporal que não nomeou.

Adesão e descontinuação: Como os desconfortos iniciais podem anteceder o benefício, a adesão irregular é uma fonte frequente de confusão clínica. O paciente pode alternar dias de uso, interromper por conta própria ou retomar de modo inconsistente, e então chegar à sessão com oscilação de humor, ansiedade, tontura, mal-estar ou sensação de “voltar tudo”, o que facilmente se mistura com recaída ou eventos de vida. A tarefa do terapeuta é reconstruir a

sequência temporal com precisão suficiente para distinguir evolução do quadro de um padrão de uso instável que merece ser comunicado."

O que observar em sessão

- **Ansiedade inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais tensos, inquietos ou com sensação de piora, o que pode ser vivido como sinal de que “não está fazendo bem” e favorecer abandono silencioso. Na sessão, isso pode aparecer como maior urgência na fala, dificuldade de permanecer com o tema ou aumento da vigilância corporal. Vale não tomar automaticamente esse movimento como agravamento do transtorno de base: a proximidade temporal com o início, a flutuação ao longo dos dias e a coexistência com outros desconfortos iniciais ajudam a discriminar.

TOC e ruminação: Quando a fluvoxamina entra em quadros obsessivo-compulsivos, a mudança mais útil para o terapeuta nem sempre é redução imediata do conteúdo obsessivo, mas alteração no tempo gasto, na urgência dos rituais e na capacidade de adiar respostas compulsivas. Em sessão, o paciente pode seguir trazendo os mesmos temas, porém com um pouco mais de distância reflexiva ou menor fusão com a urgência. Isso pode se confundir com oscilação natural do TOC, efeito de intervenções psicoterápicas ou variações de estresse ambiental, por isso convém observar tendência ao longo de semanas, não apenas uma sessão isolada.

Sono e ativação: O padrão de sono pode mudar para mais insônia, sono fragmentado ou, em alguns casos, mais sonolência e lentificação subjetiva. No consultório, isso aparece como fadiga, bocejos, dificuldade de concentração ou, no polo oposto, aceleração e menor tolerância ao silêncio. A leitura pode se embaralhar com depressão, rotina desorganizada, uso de cafeína, outras medicações e ansiedade antecipatória; por isso ajuda mapear se a alteração surgiu junto com o início do medicamento e se varia de forma diferente do humor.

Embotamento afetivo: Depois das primeiras semanas, parte dos pacientes descreve menos sofrimento, mas também menos acesso afetivo, como se estivessem “mais estáveis” e ao mesmo tempo menos tocados. Na sessão, isso pode ser percebido como narrativa mais plana, menor ressonância emocional e redução da reatividade, sem necessariamente corresponder a elaboração maior. O ponto clínico é diferenciar melhora real da depressão ou da ansiedade de um achatamento subjetivo que o paciente vive como perda de vitalidade, porque essa diferença muda a leitura da adesão e do vínculo com o tratamento.

Sexualidade: Dificuldades de desejo, excitação ou orgasmo podem surgir e muitas vezes ficam fora do relato espontâneo, embora tenham peso importante na autoestima, na vida conjugal e na continuidade do uso. Em sessão, o tema pode aparecer deslocado como afastamento do parceiro, irritação relacional ou sensação de estranhamento com o próprio corpo. Sem investigação cuidadosa, isso pode ser lido apenas como conflito de casal, piora depressiva ou desinteresse afetivo, quando às vezes o paciente está tentando acomodar uma mudança corporal que não nomeou.

Adesão e descontinuação: Como os desconfortos iniciais podem anteceder o benefício, a adesão irregular é uma fonte frequente de confusão clínica. O paciente pode alternar dias de uso, interromper por conta própria ou retomar de modo inconsistente, e então chegar à sessão com oscilação de humor, ansiedade, tontura, mal-estar ou sensação de “voltar tudo”, o que facilmente se mistura com recaída ou eventos de vida. A tarefa do terapeuta é reconstruir a

sequência temporal com precisão suficiente para distinguir evolução do quadro de um padrão de uso instável que merece ser comunicado.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A fluvoxamina é um antidepressivo ISRS que costuma aparecer no consultório sobretudo em pacientes com TOC, depressão e quadros ansiosos. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta tende a acompanhar mais de perto piora subjetiva de ansiedade, desconforto gastrointestinal, alteração do sono e oscilação de tolerabilidade, que podem interferir na adesão antes de qualquer benefício percebido. Em depressão e ansiedade, alguma mudança clínica costuma ser buscada ao longo de 2 a 6 semanas; em sintomas obsessivo-compulsivos, a leitura costuma exigir mais tempo, frequentemente entre 6 e 12 semanas. O ponto central na sessão é diferenciar ativação inicial, melhora parcial, embotamento, adesão irregular e evolução do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está pior, isso se parece mais com a sua ansiedade habitual ou com uma inquietação diferente que começou depois que o remédio entrou na rotina? , Nas últimas semanas, os pensamentos obsessivos diminuíram em conteúdo, ou o que mudou foi mais o tempo que você fica preso neles e a urgência de fazer algo para aliviar? , Esse cansaço e essa dificuldade de se concentrar vieram junto com mais tristeza e desânimo, ou apareceram mesmo sem piora clara do humor? , Quando você se sente mais "estável", isso vem com sensação de alívio e maior liberdade, ou com a impressão de estar meio amortecido e menos conectado ao que sente? , Na sua vida sexual, o que mudou mais: o interesse pelo parceiro, o desejo em geral, ou a resposta do corpo apesar de o interesse continuar? , Teve dias em que você pulou, interrompeu ou retomou o remédio de um jeito diferente, e isso coincidiu com essas oscilações que você percebeu?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente relata piora importante de ansiedade
- inquietação ou insônia nas primeiras semanas a ponto de comprometer permanência no tratamento
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar a intensidade da reação e o risco de abandono silencioso
- Quando surgem sinais de possível virada de humor
- como redução importante da necessidade de sono com aumento de energia
- impulsividade e expansividade fora do padrão
- pode valer comunicar o médico assistente para reavaliação clínica
- Quando a adesão parece irregular
- com interrupções ou retomadas por conta própria associadas a oscilação clínica
- pode valer alinhar com o psiquiatra para evitar que o quadro seja lido apenas como recaída

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve embotamento afetivo persistente ou prejuízo sexual com impacto relevante no vínculo
- na autoestima ou na continuidade do uso
- pode valer comunicar o médico assistente pela chance de isso estar sustentando baixa adesão
- Quando não há mudança perceptível após um período compatível de acompanhamento
- especialmente em TOC após várias semanas
- pode valer alinhar com o psiquiatra para compartilhar a observação longitudinal da sessão

Vermelho: tratar como urgência

- Surge fala sobre morte
- autoagressão ou desesperança intensa em início recente de tratamento
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- com sensação de piora rápida.: Fazer avaliação de risco na própria sessão e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente aparece com redução acentuada da necessidade de sono
- aceleração incomum
- grandiosidade
- impulsividade ou desorganização que foge claramente da linha de base.: Tratar como mudança aguda relevante e buscar contato médico no mesmo dia
- além de avaliar contenção e apoio imediato
- Durante a sessão
- aparecem confusão importante
- agitação intensa
- tremor evidente
- sudorese e piora física aguda sem explicação clara.: Interromper a condução usual da sessão e encaminhar para avaliação médica imediata
- acionando emergência se houver progressão rápida ou rebaixamento clínico

Frase clínica

Na fluvoxamina, o foco é separar ativação inicial, mudança real em TOC e ansiedade, e sinais de adesão irregular que confundem a leitura da sessão.

115 OXALATO DE ESCITALOPRAM

Substância: Oxalato de Escitalopram.

Nomes Comerciais: Reconter, Reconter Odt, Esc, Oxalato de Escitalopram, Esc Odt, Escena, Unitram, Lexapro, Eudok, Espran, Exodus, Fusor, Mind, Escilex, Sytoc, Deciprax, Eficentus

Uso comum

- O oxalato de escitalopram é um antidepressivo da classe dos ISRSs, frequente em quadros de depressão e transtornos de ansiedade. Na prática do consultório, alguma piora subjetiva de ansiedade, inquietação, náusea ou alteração do sono pode aparecer nos primeiros dias e semanas, enquanto sinais de benefício costumam ficar mais nítidos ao longo de 2 a 6 semanas. Em interrupção irregular ou abrupta, podem surgir mal-estar, tontura, sensação de instabilidade e aumento de irritabilidade em poucos dias. O ponto central na sessão é diferenciar ativação inicial, melhora gradual do quadro, embotamento afetivo e oscilação ligada à adesão.

O paciente pode relatar

- **"Ansiedade inicial:** No início do uso, alguns pacientes chegam mais tensos, inquietos ou com sensação de aceleração interna, o que pode ser confundido com piora do transtorno de ansiedade, estresse recente ou expectativa em torno do tratamento. Vale observar se a ansiedade aparece como continuação do padrão prévio ou se ganhou uma qualidade mais corporal, mais aguda e temporalmente próxima do início da medicação. Também ajuda notar se essa mudança convive com manutenção da capacidade reflexiva ou se o paciente parece apenas mais reativo e desconfortável na sessão.

Humor e resposta: Ao longo de algumas semanas, pode surgir redução de choro, menor desesperança e mais disponibilidade para a rotina, mas nem sempre isso significa remissão consistente. Em sessão, a melhora pode aparecer como maior acesso à elaboração e menos ruminação, embora eventos de vida favoráveis também possam explicar parte da mudança. Quando nada se altera após um período razoável, ou quando há oscilação marcada entre sessões, convém considerar adesão irregular, uso intermitente ou leitura excessivamente otimista de uma melhora ainda frágil.

Embotamento afetivo: Parte dos pacientes descreve estar menos sofrendo, mas também menos tocada, menos espontânea ou com sensação de estar anestesiada. Isso pode se confundir com alívio legítimo de sintomas depressivos, defesa psíquica diante de sobrecarga ou retraimento relacional. Na sessão, o contraste entre redução de angústia e empobrecimento do acesso afetivo, da iniciativa ou da ressonância emocional costuma ser mais útil do que tomar a melhora aparente como sinal inequívoco de evolução.

Sono e energia: Mudanças no sono podem aparecer tanto no começo quanto ao longo do acompanhamento: mais sonolência, sono fragmentado ou, em alguns casos, maior alerta. O terapeuta pode observar lentificação, bocejos, dificuldade de sustentar atenção ou, no polo oposto, inquietação e fala mais apressada, mas esses sinais também podem decorrer de depressão, ansiedade, privação de sono ou outras substâncias. A leitura fica mais precisa quando se compara o padrão atual com a baseline e com o horário em que o paciente costuma perceber piora ou alívio.

Sexualidade: Queda de desejo, dificuldade de excitação ou atraso para atingir orgasmo podem surgir mesmo quando o humor melhora, e muitas vezes o paciente só menciona isso se houver espaço clínico direto. Na psicoterapia, isso pode aparecer como afastamento do parceiro, vergonha, sensação de inadequação ou interpretação relacional equivocada do problema. Também é um ponto em que conflitos conjugais prévios, sintomas depressivos residuais e silêncio por constrangimento podem confundir a leitura e favorecer abandono silencioso do tratamento.

Adesão e descontinuação: Faltas esporádicas, esquecimento de tomadas ou interrupção por conta própria podem produzir oscilações que lembram recaída, instabilidade emocional ou piora ansiosa. Em sessão, o paciente pode descrever alguns dias de mal-estar, irritabilidade, tontura, sensação de cabeça estranha ou piora abrupta sem um gatilho psicológico claro, especialmente após mudanças na rotina. Quando o padrão é serrilhado entre sessões, vale considerar adesão irregular antes de concluir que houve falha terapêutica ou agravamento primário do quadro."

O que observar em sessão

- **Ansiedade inicial:** No início do uso, alguns pacientes chegam mais tensos, inquietos ou com sensação de aceleração interna, o que pode ser confundido com piora do transtorno de ansiedade, estresse recente ou expectativa em torno do tratamento. Vale observar se a ansiedade aparece como continuação do padrão prévio ou se ganhou uma qualidade mais corporal, mais aguda e temporalmente próxima do início da medicação. Também ajuda notar se essa mudança convive com manutenção da capacidade reflexiva ou se o paciente parece apenas mais reativo e desconfortável na sessão.

Humor e resposta: Ao longo de algumas semanas, pode surgir redução de choro, menor desesperança e mais disponibilidade para a rotina, mas nem sempre isso significa remissão consistente. Em sessão, a melhora pode aparecer como maior acesso à elaboração e menos ruminação, embora eventos de vida favoráveis também possam explicar parte da mudança. Quando nada se altera após um período razoável, ou quando há oscilação marcada entre sessões, convém considerar adesão irregular, uso intermitente ou leitura excessivamente otimista de uma melhora ainda frágil.

Embotamento afetivo: Parte dos pacientes descreve estar menos sofrendo, mas também menos tocada, menos espontânea ou com sensação de estar "anestesiada". Isso pode se confundir com alívio legítimo de sintomas depressivos, defesa psíquica diante de sobrecarga ou retraimento relacional. Na sessão, o contraste entre redução de angústia e empobrecimento do acesso afetivo, da iniciativa ou da ressonância emocional costuma ser mais útil do que tomar a melhora aparente como sinal inequívoco de evolução.

Sono e energia: Mudanças no sono podem aparecer tanto no começo quanto ao longo do acompanhamento: mais sonolência, sono fragmentado ou, em alguns casos, maior alerta. O terapeuta pode observar lentificação, bocejos, dificuldade de sustentar atenção ou, no polo oposto, inquietação e fala mais apressada, mas esses sinais também podem decorrer de depressão, ansiedade, privação de sono ou outras substâncias. A leitura fica mais precisa quando se compara o padrão atual com a baseline e com o horário em que o paciente costuma perceber piora ou alívio.

Sexualidade: Queda de desejo, dificuldade de excitação ou atraso para atingir orgasmo podem surgir mesmo quando o humor melhora, e muitas vezes o paciente só menciona isso se houver espaço clínico direto. Na psicoterapia, isso pode aparecer como afastamento do parceiro, vergonha, sensação de inadequação ou interpretação relacional equivocada do problema. Também é um ponto em que conflitos conjugais prévios, sintomas depressivos residuais e silêncio por constrangimento podem confundir a leitura e favorecer abandono silencioso do tratamento.

Adesão e descontinuação: Faltas esporádicas, esquecimento de tomadas ou interrupção por conta própria podem produzir oscilações que lembram recaída, instabilidade emocional ou piora ansiosa. Em sessão, o paciente pode descrever alguns dias de mal-estar, irritabilidade, tontura, sensação de "cabeça estranha" ou piora abrupta sem um gatilho psicológico claro, especialmente após mudanças na rotina. Quando o padrão é serrilhado entre sessões, vale considerar adesão irregular antes de concluir que houve falha terapêutica ou agravamento

primário do quadro.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O oxalato de escitalopram é um antidepressivo da classe dos ISRSs, frequente em quadros de depressão e transtornos de ansiedade. Na prática do consultório, alguma piora subjetiva de ansiedade, inquietação, náusea ou alteração do sono pode aparecer nos primeiros dias e semanas, enquanto sinais de benefício costumam ficar mais nítidos ao longo de 2 a 6 semanas. Em interrupção irregular ou abrupta, podem surgir mal-estar, tontura, sensação de instabilidade e aumento de irritabilidade em poucos dias. O ponto central na sessão é diferenciar ativação inicial, melhora gradual do quadro, embotamento afetivo e oscilação ligada à adesão.

Perguntas úteis

- "Essa piora da ansiedade se parece com a sua ansiedade habitual ou tem uma qualidade mais física, de inquietação e aceleração, que começou depois da medicação? , Quando você diz que está melhor, sente também mais interesse e presença emocional, ou está apenas sofrendo menos e ficando mais anestesiado? , Esses dias em que você piorou vieram junto de algum esquecimento, pausa ou mudança no uso, ou aconteceram mesmo mantendo a rotina habitual? , A dificuldade sexual apareceu junto de conflitos na relação e perda de interesse pelo parceiro, ou surgiu mesmo quando o vínculo e o desejo de proximidade seguem presentes? , Seu cansaço atual parece o mesmo desânimo depressivo de antes, ou é mais uma sonolência/lentificação que apareceu apesar de alguma melhora do humor? , Esse aumento de energia veio com mais clareza e organização, ou com menos necessidade de sono, impulsividade e sensação de estar acelerado demais para o seu padrão?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta inquietação importante
- piora nítida da ansiedade ou insônia logo após o início
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar a intensidade e o impacto funcional dessa mudança
- Quando surge embotamento afetivo persistente
- com redução do sofrimento às custas de empobrecimento importante da vida emocional e relacional
- pode valer comunicar o médico assistente para qualificar a tolerabilidade clínica
- Quando aparecem efeitos na sexualidade que estão levando a evitação íntima
- conflito conjugal ou intenção de abandonar o tratamento sem dizer ao médico
- pode valer alinhar com o psiquiatra para prevenir interrupção silenciosa
- Quando há oscilação abrupta de sintomas entre sessões e o paciente relata esquecimentos
- pausas ou uso irregular
- pode valer comunicar o médico assistente para contextualizar a leitura clínica da resposta ao tratamento
- Quando

Amarelo: alinhar em breve

- após 4 a 6 semanas de uso aparentemente regular
- não se observa mudança clínica relevante ou há piora sustentada
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisão do quadro e da adesão
- Quando surgem sinais de aceleração incomum do humor
- redução importante da necessidade de sono
- impulsividade ou expansividade fora do padrão
- pode valer contato com o psiquiatra pela possibilidade de mudança de polaridade em paciente vulnerável

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a falar em morte
- desesperança mais aguda
- impulso de se ferir ou planejamento suicida.: Avalie risco imediatamente
- acione psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhe para emergência quando houver risco iminente
- O paciente chega muito acelerado
- dormindo muito menos sem cansaço
- mais impulsivo
- grandioso ou desorganizado
- em contraste claro com a baseline.: Contate o psiquiatra no mesmo dia para informar a mudança e organize contenção clínica e rede de apoio conforme o grau de risco

Frase clínica

No escitalopram, o foco é separar melhora gradual de ativação inicial, embotamento afetivo e oscilações ligadas à adesão.

116 CLORIDRATO DE DULOXETINA

Substância: Cloridrato de Duloxetina.

Nomes Comerciais: Velija, Cloridrato de Duloxetina, Dep, Sympta, Abretia, Leduo, Dual, Mydulo, Cymbalta, Cymbi, Deprasil, Duxxen

Uso comum

- A duloxetina é um antidepressivo de uso comum em quadros depressivos e ansiosos, e também pode aparecer em pacientes com dor crônica, o que muda bastante o tom da sessão. Nas primeiras 1 a 2 semanas, alguns pacientes ficam mais ativados, nauseados, insones ou irritáveis, antes de qualquer benefício subjetivo mais claro. Quando há resposta, ela costuma começar a se delinear entre 2 e 6 semanas, às vezes com melhora funcional antes de maior acesso afetivo. Interrupções abruptas ou uso irregular podem produzir mal-estar em poucos dias, confundindo recaída, ansiedade e piora do humor. O ponto central na sessão é diferenciar melhora do quadro, efeitos iniciais, impacto sobre dor e sinais de adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Ativação inicial:** No começo do uso, pode surgir uma combinação de inquietação, irritabilidade, aceleração interna e piora subjetiva da ansiedade, às vezes em contraste com a expectativa de alívio rápido. Em sessão, isso pode aparecer como fala mais tensa, menor tolerância à frustração e sensação de estar "ligado demais", sem que isso signifique necessariamente agravamento do transtorno de base. Vale observar a proximidade temporal com o início do medicamento e distinguir esse estado de ansiedade habitual, estresse recente ou uma expansão de humor mais ampla, com redução importante do sono e aumento de impulsividade.

Humor e ansiedade: Ao longo das semanas, alguns pacientes descrevem redução de ruminação, menor reatividade e mais capacidade de atravessar o dia, enquanto outros referem melhora parcial, com menos ansiedade mas persistência de vazio, desesperança ou anedonia. Na sessão, isso pode se traduzir em maior organização narrativa sem correspondente ampliação do contato afetivo, o que pede cuidado para não confundir contenção sintomática com elaboração. Também entram como confundidores eventos de vida, psicoterapia em curso, dor física flutuante e adesão irregular, que podem produzir uma impressão de resposta instável.

Sono e energia: A duloxetine tanto pode vir acompanhada de insônia inicial e sensação de ativação quanto de cansaço, sonolência ou fadiga subjetiva em parte dos pacientes. O terapeuta pode notar bocejos, lentificação, dificuldade de sustentar atenção ou, no polo oposto, um paciente mais desperto porém menos repousado. A leitura clínica fica mais precisa quando se discrimina se a energia mudou ao longo do dia, se o sono piorou logo após o início ou retomada, e se a fadiga se parece mais com sedação, exaustão depressiva ou sobrecarga da dor crônica.

Dor e funcionalidade: Como muitos pacientes usam duloxetine também por dor crônica, a sessão pode mudar não apenas pelo humor, mas pelo quanto o corpo deixa ou não de ocupar o centro da experiência. Às vezes há melhora funcional antes de uma mudança emocional mais nítida; em outros casos, a dor persiste e contamina a leitura de "falta de efeito" sobre o humor. Convém observar se o paciente voltou a fazer pequenas atividades, tolera melhor deslocamentos ou retoma compromissos, porque isso ajuda a diferenciar ausência de resposta global de benefício parcial encoberto pelo sofrimento físico.

Sexualidade: Queda de libido, dificuldade de excitação ou de orgasmo podem aparecer e, por vergonha, ficar fora do relato espontâneo, embora tenham impacto direto no humor, na autoestima e na adesão silenciosa. Em sessão, isso às vezes surge como afastamento do parceiro, irritação relacional ou sensação de estranhamento com o próprio corpo, podendo ser confundido com conflito conjugal, depressão residual ou retraimento ansioso. Quando o tema é nomeado com cuidado, costuma ajudar a discriminar desinteresse afetivo do parceiro de uma mudança mais ligada ao período após o início do medicamento.

Adesão e descontinuação: Esquecimentos, interrupções por conta própria e retomadas irregulares podem produzir oscilação clínica difícil de ler, com tontura, mal-estar, irritabilidade, sensação de instabilidade e piora abrupta do humor ou da ansiedade em poucos dias. Na sessão, esse padrão pode parecer recaída, resistência ao tratamento ou "medicação que não funciona", quando na verdade a linha de base foi quebrada por uso inconsistente. Vale prestar atenção a mudanças muito rápidas após fins de semana, viagens, falta de receita ou abandono

silencioso motivado por efeitos incômodos."

O que observar em sessão

- **Ativação inicial:** No começo do uso, pode surgir uma combinação de inquietação, irritabilidade, aceleração interna e piora subjetiva da ansiedade, às vezes em contraste com a expectativa de alívio rápido. Em sessão, isso pode aparecer como fala mais tensa, menor tolerância à frustração e sensação de estar “ligado demais”, sem que isso signifique necessariamente agravamento do transtorno de base. Vale observar a proximidade temporal com o início do medicamento e distinguir esse estado de ansiedade habitual, estresse recente ou uma expansão de humor mais ampla, com redução importante do sono e aumento de impulsividade.

Humor e ansiedade: Ao longo das semanas, alguns pacientes descrevem redução de ruminação, menor reatividade e mais capacidade de atravessar o dia, enquanto outros referem melhora parcial, com menos ansiedade mas persistência de vazio, desesperança ou anedonia. Na sessão, isso pode se traduzir em maior organização narrativa sem correspondente ampliação do contato afetivo, o que pede cuidado para não confundir contenção sintomática com elaboração. Também entram como confundidores eventos de vida, psicoterapia em curso, dor física flutuante e adesão irregular, que podem produzir uma impressão de resposta instável.

Sono e energia: A duloxetine tanto pode vir acompanhada de insônia inicial e sensação de ativação quanto de cansaço, sonolência ou fadiga subjetiva em parte dos pacientes. O terapeuta pode notar bocejos, lentificação, dificuldade de sustentar atenção ou, no polo oposto, um paciente mais desperto porém menos repousado. A leitura clínica fica mais precisa quando se discrimina se a energia mudou ao longo do dia, se o sono piorou logo após o início ou retomada, e se a fadiga se parece mais com sedação, exaustão depressiva ou sobrecarga da dor crônica.

Dor e funcionalidade: Como muitos pacientes usam duloxetine também por dor crônica, a sessão pode mudar não apenas pelo humor, mas pelo quanto o corpo deixa ou não de ocupar o centro da experiência. Às vezes há melhora funcional antes de uma mudança emocional mais nítida; em outros casos, a dor persiste e contamina a leitura de “falta de efeito” sobre o humor. Convém observar se o paciente voltou a fazer pequenas atividades, tolera melhor deslocamentos ou retoma compromissos, porque isso ajuda a diferenciar ausência de resposta global de benefício parcial encoberto pelo sofrimento físico.

Sexualidade: Queda de libido, dificuldade de excitação ou de orgasmo podem aparecer e, por vergonha, ficar fora do relato espontâneo, embora tenham impacto direto no humor, na autoestima e na adesão silenciosa. Em sessão, isso às vezes surge como afastamento do parceiro, irritação relacional ou sensação de estranhamento com o próprio corpo, podendo ser confundido com conflito conjugal, depressão residual ou retraimento ansioso. Quando o tema é nomeado com cuidado, costuma ajudar a discriminar desinteresse afetivo do parceiro de uma mudança mais ligada ao período após o início do medicamento.

Adesão e descontinuação: Esquecimentos, interrupções por conta própria e retomadas irregulares podem produzir oscilação clínica difícil de ler, com tontura, mal-estar, irritabilidade, sensação de instabilidade e piora abrupta do humor ou da ansiedade em poucos dias. Na sessão, esse padrão pode parecer recaída, resistência ao tratamento ou “medicação que não funciona”, quando na verdade a linha de base foi quebrada por uso inconsistente. Vale prestar atenção a mudanças muito rápidas após fins de semana, viagens, falta de receita ou abandono

silencioso motivado por efeitos incômodos.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A duloxetine é um antidepressivo de uso comum em quadros depressivos e ansiosos, e também pode aparecer em pacientes com dor crônica, o que muda bastante o tom da sessão. Nas primeiras 1 a 2 semanas, alguns pacientes ficam mais ativados, nauseados, insones ou irritáveis, antes de qualquer benefício subjetivo mais claro. Quando há resposta, ela costuma começar a se delinear entre 2 e 6 semanas, às vezes com melhora funcional antes de maior acesso afetivo. Interrupções abruptas ou uso irregular podem produzir mal-estar em poucos dias, confundindo recaída, ansiedade e piora do humor. O ponto central na sessão é diferenciar melhora do quadro, efeitos iniciais, impacto sobre dor e sinais de adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando essa piora da ansiedade apareceu, ela começou junto com o início ou retomada do remédio, ou já vinha se desenhando antes por causa de algo da sua vida? , Você sente que está menos triste porque está melhor por dentro, ou mais "anestesiado", com menos acesso tanto ao sofrimento quanto ao prazer? , Nos dias em que esquece, atrasa ou interrompe o uso, o que muda primeiro: seu humor, seu corpo, seu sono ou sua sensação de equilíbrio? , Essa queda no interesse sexual parece mais uma mudança no seu vínculo e desejo pelo parceiro, ou uma dificuldade corporal que começou depois dessa fase do tratamento? , Quando sua energia sobe, isso vem com mais clareza e disposição organizada, ou com agitação, impaciência e dificuldade de desacelerar? , A melhora que você percebe apareceu também no corpo e na rotina, como conseguir fazer coisas apesar da dor, ou ficou restrita a se sentir um pouco menos angustiado?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta piora importante de ansiedade
- irritabilidade ou agitação nas primeiras semanas
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a mudança no tempo e acompanhar risco de abandono ou desorganização clínica
- Quando surgem sinais de melhora parcial
- mas com embotamento afetivo marcante ou prejuízo sexual que o paciente tende a ocultar
- pode valer comunicar ao médico porque esses fatores frequentemente pesam na adesão
- Quando há esquecimentos frequentes
- interrupções por conta própria ou retomadas repetidas com oscilação abrupta do estado subjetivo
- pode valer alinhar com o médico para esclarecer o padrão de uso e evitar leituras equivocadas de recaída
- Quando o paciente permanece sem mudança clínica relevante após um período compatível com observação de resposta
- pode valer comunicar ao médico para contextualizar a evolução funcional e subjetiva acompanhada na terapia

Amarelo: alinhar em breve

- Quando aparecem redução importante do sono
- aceleração incomum
- impulsividade ou expansividade fora do padrão
- pode valer contato com o médico para discutir possível mudança de polaridade ou ativação excessiva

Vermelho: tratar como urgência

- Surge ideação suicida nova ou claramente intensificada
- sobretudo no início do tratamento ou em adolescentes e adultos jovens.: Fazer avaliação de risco imediata
- acionar o médico no mesmo dia e mobilizar rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente chega muito acelerado
- dormindo pouco sem cansaço
- mais impulsivo
- grandioso ou fora do seu padrão habitual.: Tratar como mudança aguda relevante
- contatar o médico no mesmo dia e avaliar necessidade de suporte adicional imediato
- Durante a sessão
- aparecem confusão importante
- sudorese intensa
- tremores marcados
- rigidez ou piora física aguda junto de alteração comportamental.: Interromper a lógica habitual da sessão e encaminhar para avaliação médica urgente
- acionando emergência se houver comprometimento importante

Frase clínica

Na terapia, o foco com duloxetina é separar ativação inicial, resposta parcial sobre humor e dor, e oscilação por adesão irregular.

117 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA

Substância: Cloridrato de Venlafaxina.

Nomes Comerciais: Venlaxin Xr, Cloridrato de Venlafaxina, Efexor, Vensate Lp, Venlafaxina, Venlift Od, Alenthus Xr, Cloridrato de Venlafaxina (Port. 344/98 L-C1), Myletin, Venforin

Uso comum

- A venlafaxina é um antidepressivo de uso frequente em depressão e transtornos de ansiedade, e costuma aparecer no consultório quando se busca redução de humor deprimido, ansiedade persistente, sintomas físicos de tensão e, em alguns casos, dor associada. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta pode notar oscilação entre ativação, náusea, piora subjetiva da ansiedade, sono mais fragmentado ou inquietação; a resposta clínica mais consistente tende a ser acompanhada ao longo de 4 a 8 semanas. Quando há uso irregular ou interrupção abrupta, podem surgir em poucos dias mal-estar, tontura, sensação de “choques”, irritabilidade e instabilidade emocional, o que facilmente se confunde com recaída. Na sessão, o ponto central é distinguir melhora real de embotamento, ativação medicamentosa de ansiedade basal e descontinuação de piora do quadro.

O paciente pode relatar

- **"Ativação inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais acelerados, inquietos ou com sensação de tensão corporal aumentada, mesmo quando procuravam tratamento justamente para ansiedade ou desânimo. Em sessão, isso pode aparecer como fala mais apressada, dificuldade de permanecer sentado, impaciência ou relato de “nervoso sem motivo claro”. Vale diferenciar esse padrão de ansiedade habitual, reação a eventos recentes e traços de agitação já presentes na baseline, além de considerar se houve início recente, retomada após pausa ou adesão irregular.

Humor e resposta: Ao longo das semanas, pode surgir melhora do humor, maior capacidade de iniciar tarefas e redução da desesperança, mas nem sempre isso vem acompanhado de recuperação do acesso afetivo. Às vezes o paciente descreve estar “menos mal” sem se sentir propriamente mais vivo, o que pode ser confundido com remissão quando há embotamento ou apenas alívio parcial. Também convém separar ausência de resposta após tempo suficiente de fatores como estressores intensos, uso intermitente, expectativas muito altas nas primeiras semanas ou oscilação natural do episódio.

Ansiedade e inquietação: A venlafaxina pode coexistir com redução gradual da ansiedade em parte dos pacientes, mas no início também pode haver aumento de apreensão, sensação de alerta excessivo ou inquietação difícil de nomear. Na sessão, isso pode se parecer tanto com piora do transtorno ansioso quanto com uma agitação mais corporal, pouco ligada a pensamentos catastróficos habituais. A discriminação clínica ganha precisão quando se observa temporalidade, padrão ao longo do dia e relação com situações externas, em vez de tomar a ansiedade como bloco único.

Sono: Mudanças no sono são frequentes no acompanhamento: alguns pacientes relatam insônia inicial, despertares ou sono mais leve, enquanto outros descrevem cansaço e sonolência. Em sessão, a aparência de fadiga pode ser lida como piora depressiva, quando às vezes acompanha adaptação inicial ao tratamento, noites fragmentadas ou combinação com outras medicações sedativas. O contraste entre linha de base, horário em que o mal-estar aparece e impacto funcional ajuda a não confundir efeito do período inicial com agravamento do quadro de base.

Sexualidade: Queda de libido, atraso ou dificuldade para chegar ao orgasmo e sensação de resposta sexual “travada” podem aparecer e, por vergonha, às vezes ficam fora do relato espontâneo. Isso pode repercutir no vínculo amoroso, na autoestima e até ser interpretado pelo paciente como perda de interesse pelo parceiro ou sinal de fracasso relacional. Na leitura clínica, convém distinguir efeito associado ao tratamento de depressão ainda ativa, conflitos conjugais prévios, dor, cansaço e evitamento sexual já existente antes do início do medicamento.

Adesão e descontinuação: A adesão irregular com venlafaxina costuma ter relevância clínica perceptível no consultório porque pequenas interrupções podem ser seguidas de mal-estar rápido, irritabilidade, tontura, sensação estranha na cabeça e labilidade emocional. O paciente pode entender isso como recaída súbita, “crise do nada” ou prova de que o tratamento não funciona, quando a temporalidade com esquecimentos ou pausas ajuda a abrir outras hipóteses. Também é um ponto importante porque efeitos incômodos, especialmente no início ou na

sexualidade, podem favorecer abandono silencioso sem que isso apareça espontaneamente."

O que observar em sessão

- **Ativação inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais acelerados, inquietos ou com sensação de tensão corporal aumentada, mesmo quando procuravam tratamento justamente para ansiedade ou desânimo. Em sessão, isso pode aparecer como fala mais apressada, dificuldade de permanecer sentado, impaciência ou relato de “nervoso sem motivo claro”. Vale diferenciar esse padrão de ansiedade habitual, reação a eventos recentes e traços de agitação já presentes na baseline, além de considerar se houve início recente, retomada após pausa ou adesão irregular.

Humor e resposta: Ao longo das semanas, pode surgir melhora do humor, maior capacidade de iniciar tarefas e redução da desesperança, mas nem sempre isso vem acompanhado de recuperação do acesso afetivo. Às vezes o paciente descreve estar “menos mal” sem se sentir propriamente mais vivo, o que pode ser confundido com remissão quando há embotamento ou apenas alívio parcial. Também convém separar ausência de resposta após tempo suficiente de fatores como estressores intensos, uso intermitente, expectativas muito altas nas primeiras semanas ou oscilação natural do episódio.

Ansiedade e inquietação: A venlafaxina pode coexistir com redução gradual da ansiedade em parte dos pacientes, mas no início também pode haver aumento de apreensão, sensação de alerta excessivo ou inquietação difícil de nomear. Na sessão, isso pode se parecer tanto com piora do transtorno ansioso quanto com uma agitação mais corporal, pouco ligada a pensamentos catastróficos habituais. A discriminação clínica ganha precisão quando se observa temporalidade, padrão ao longo do dia e relação com situações externas, em vez de tomar a ansiedade como bloco único.

Sono: Mudanças no sono são frequentes no acompanhamento: alguns pacientes relatam insônia inicial, despertares ou sono mais leve, enquanto outros descrevem cansaço e sonolência. Em sessão, a aparência de fadiga pode ser lida como piora depressiva, quando às vezes acompanha adaptação inicial ao tratamento, noites fragmentadas ou combinação com outras medicações sedativas. O contraste entre linha de base, horário em que o mal-estar aparece e impacto funcional ajuda a não confundir efeito do período inicial com agravamento do quadro de base.

Sexualidade: Queda de libido, atraso ou dificuldade para chegar ao orgasmo e sensação de resposta sexual “travada” podem aparecer e, por vergonha, às vezes ficam fora do relato espontâneo. Isso pode repercutir no vínculo amoroso, na autoestima e até ser interpretado pelo paciente como perda de interesse pelo parceiro ou sinal de fracasso relacional. Na leitura clínica, convém distinguir efeito associado ao tratamento de depressão ainda ativa, conflitos conjugais prévios, dor, cansaço e evitamento sexual já existente antes do início do medicamento.

Adesão e descontinuação: A adesão irregular com venlafaxina costuma ter relevância clínica perceptível no consultório porque pequenas interrupções podem ser seguidas de mal-estar rápido, irritabilidade, tontura, sensação estranha na cabeça e labilidade emocional. O paciente pode entender isso como recaída súbita, “crise do nada” ou prova de que o tratamento não funciona, quando a temporalidade com esquecimentos ou pausas ajuda a abrir outras hipóteses. Também é um ponto importante porque efeitos incômodos, especialmente no início ou na

sexualidade, podem favorecer abandono silencioso sem que isso apareça espontaneamente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A venlafaxina é um antidepressivo de uso frequente em depressão e transtornos de ansiedade, e costuma aparecer no consultório quando se busca redução de humor deprimido, ansiedade persistente, sintomas físicos de tensão e, em alguns casos, dor associada. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta pode notar oscilação entre ativação, náusea, piora subjetiva da ansiedade, sono mais fragmentado ou inquietação; a resposta clínica mais consistente tende a ser acompanhada ao longo de 4 a 8 semanas. Quando há uso irregular ou interrupção abrupta, podem surgir em poucos dias mal-estar, tontura, sensação de “choques”, irritabilidade e instabilidade emocional, o que facilmente se confunde com recaída. Na sessão, o ponto central é distinguir melhora real de embotamento, ativação medicamentosa de ansiedade basal e descontinuação de piora do quadro.

Perguntas úteis

- "Quando essa piora da ansiedade apareceu, ela veio junto de pensamentos e medos que você já reconhece como seus, ou foi mais uma inquietação corporal e um estado de alerta difícil de explicar? , Esse desânimo que persiste parece uma tristeza com sofrimento e ruminação, ou você se percebe mais “anestesiado”, com menos intensidade emocional tanto para o ruim quanto para o bom? , Nos dias em que você se sentiu pior, houve algum esquecimento, atraso ou interrupção do remédio que tenha acontecido pouco antes dessas sensações? , A dificuldade sexual apareceu como perda de interesse pelo parceiro e pela intimidade, ou como vontade preservada com o corpo respondendo de um jeito diferente? , Essa agitação que você nota lembra seu padrão habitual de ansiedade, ou parece algo novo no corpo, mais contínuo e menos ligado ao que está acontecendo na sua vida? , Quando o sono piorou, isso veio acompanhado de mais energia e aceleração durante o dia, ou de cansaço, peso e piora global do humor?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve piora importante da inquietação
- ansiedade ou insônia nas primeiras semanas a ponto de comprometer funcionamento ou adesão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar a intensidade e o impacto clínico
- Quando surgem sinais de abandono silencioso
- esquecimentos frequentes ou interrupções por conta própria
- pode valer alinhar com o psiquiatra porque a leitura da resposta clínica fica muito confusa e o risco de descontinuação aumenta
- Quando há queixa sexual persistente com repercussão importante na relação
- na autoestima ou na continuidade do tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente para que ele tenha esse dado na condução
- Quando
- após cerca de 6 a 8 semanas de uso aparentemente regular

Amarelo: alinhar em breve

- não se observa melhora minimamente consistente do quadro-alvo
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisão da hipótese clínica e da adesão
- Quando o paciente passa a apresentar redução acentuada da necessidade de sono
- aumento incomum de energia
- impulsividade ou expansividade fora do seu padrão
- pode valer comunicação com o psiquiatra pela possibilidade de mudança relevante do estado de humor

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente chega muito acelerado
- dormindo muito pouco sem cansaço
- com fala pressionada
- impulsividade aumentada
- grandiosidade ou comportamento claramente fora do seu padrão.: Tratar como possível mudança aguda do estado de humor
- acionar o psiquiatra no mesmo dia e mobilizar rede de apoio e avaliação de urgência se houver risco comportamental
- Durante a sessão aparecem confusão importante
- agitação intensa
- tremores marcados
- sudorese
- febre referida ou piora física rápida sem explicação clara.: Interromper a lógica habitual da sessão e encaminhar para avaliação médica imediata
- acionando emergência se o estado geral estiver comprometido
- Há ideação suicida atual com plano
- intenção
- meios disponíveis ou incapacidade de combinar proteção mínima.: Manejar como urgência no mesmo dia
- acionando rede de apoio
- psiquiatra e serviço de emergência conforme necessidade

Frase clínica

Com venlafaxina, o foco é separar ativação inicial, resposta parcial e descontinuação de uma piora primária do quadro.

118 SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO

Substância: Succinato de Desvenlafaxina Monoidratado.

Nomes Comerciais: Succinato de Desvenlafaxina Monoidratado, Desve, Vendexla, Imense, Vellana, Succinato de Desvenlafaxina, Andes, Desdiff, Desduo, Desenvo, Deller, Desventag, Rytmise, Pristiq, Elifore, Afax, Destyc, Vyxara, Aviv, Zodel

Uso comum

- A desvenlafaxina é um antidepressivo usado sobretudo em quadros depressivos e, em alguns casos, quando há ansiedade associada. No consultório, as primeiras 1 a 2 semanas costumam ser o período em que mais aparecem oscilação entre náusea, ativação, piora subjetiva da ansiedade, insônia ou sonolência e dúvidas sobre continuidade; sinais de benefício tendem a ficar mais claros entre 2 e 6 semanas, às vezes com melhora funcional antes de uma mudança afetiva mais nítida. Se houver interrupção abrupta ou uso irregular, nos dias seguintes podem surgir mal-estar, tontura, irritabilidade e sensação de “estranheza”, o que pode se confundir com recaída. O ponto central na sessão é diferenciar ativação inicial, resposta parcial, embotamento e descontinuação de mudanças do próprio quadro.

O paciente pode relatar

- **"Ativação inicial:** No início do uso, alguns pacientes chegam mais acelerados, inquietos, com sensação de tensão interna, pior tolerância a espera e sono mais leve. Em sessão, isso pode parecer ansiedade habitual ou reatividade a eventos de vida, mas vale observar se houve mudança de ritmo, fala, impaciência corporal ou aumento de agitação em relação à baseline logo após o início. Quando a intensidade cresce nas primeiras semanas, a leitura clínica precisa considerar tanto efeito inicial quanto agravamento do quadro ansioso ou adesão irregular.

Humor e resposta: A melhora pode aparecer primeiro como maior capacidade de sair da inércia, retomar tarefas e comparecer à sessão com mais energia, sem que o sofrimento afetivo tenha mudado na mesma velocidade. Isso pode ser confundido com remissão mais robusta do que de fato ocorreu, ou, no sentido oposto, com ausência de resposta quando o paciente já recuperou algum funcionamento. Vale acompanhar se há ampliação real de interesse, esperança e elaboração, ou apenas redução parcial de lentificação e evitação.

Ansiedade: Ao longo das primeiras semanas, a ansiedade pode oscilar: em alguns casos diminui com a melhora do humor, em outros fica mais saliente no começo e depois cede. Na sessão, ajuda notar se a apreensão está ligada a temas reconhecíveis da vida psíquica e relacional ou se aparece como tensão mais difusa, corporal, pouco simbolizada e temporalmente próxima do início do medicamento. Também convém considerar cafeína, outros estimulantes, privação de sono e estressores recentes antes de atribuir a mudança ao remédio.

Sono: Insônia inicial, sono fragmentado ou, em parte dos pacientes, sonolência e sensação de cansaço podem alterar o padrão da sessão e a capacidade de elaboração. O terapeuta pode encontrar mais fadiga, menor tolerância à frustração, dificuldade de concentração ou irritabilidade, o que tanto pode decorrer do medicamento quanto da própria depressão, de ansiedade noturna ou de rotina desorganizada. A discriminação melhora quando se observa a relação temporal entre início do uso, mudança no sono e oscilação do funcionamento diurno.

Sexualidade: Redução de desejo, dificuldade de excitação ou atraso para atingir orgasmo podem surgir e muitas vezes não aparecem espontaneamente, embora afetem vínculo, autoestima e adesão. Em sessão, isso pode ser confundido com distanciamento afetivo do parceiro, conflito conjugal, humor deprimido residual ou vergonha corporal. Quando a mudança sexual coincide com o início do tratamento e contrasta com o padrão anterior, vale registrar porque esse é um motivo frequente de abandono silencioso.

Adesão e descontinuação: Esquecimentos, pausas de alguns dias, uso irregular em fins de semana ou interrupção por conta própria podem produzir mal-estar, irritabilidade, tontura, sensação de instabilidade e piora subjetiva abrupta. Na sessão, esse quadro às vezes parece recaída depressiva ou aumento de ansiedade, mas a pista costuma estar na cronologia curta e no caráter mais corporal e súbito da mudança. Como muitos pacientes omitem falhas por vergonha ou por acharem que "não faz diferença", perguntas diretas e não moralizantes ajudam a leitura clínica."

O que observar em sessão

- **Ativação inicial:** No início do uso, alguns pacientes chegam mais acelerados, inquietos, com sensação de tensão interna, pior tolerância a espera e sono mais leve. Em sessão, isso pode parecer ansiedade habitual ou reatividade a eventos de vida, mas vale observar se houve mudança de ritmo, fala, impaciência corporal ou aumento de agitação em relação à baseline logo após o início. Quando a intensidade cresce nas primeiras semanas, a leitura clínica precisa considerar tanto efeito inicial quanto agravamento do quadro ansioso ou adesão irregular.

Humor e resposta: A melhora pode aparecer primeiro como maior capacidade de sair da inércia, retomar tarefas e comparecer à sessão com mais energia, sem que o sofrimento afetivo tenha mudado na mesma velocidade. Isso pode ser confundido com remissão mais robusta do que de fato ocorreu, ou, no sentido oposto, com ausência de resposta quando o paciente já recuperou algum funcionamento. Vale acompanhar se há ampliação real de interesse, esperança e elaboração, ou apenas redução parcial de lentificação e evitação.

Ansiedade: Ao longo das primeiras semanas, a ansiedade pode oscilar: em alguns casos diminui com a melhora do humor, em outros fica mais saliente no começo e depois cede. Na sessão, ajuda notar se a apreensão está ligada a temas reconhecíveis da vida psíquica e relacional ou se aparece como tensão mais difusa, corporal, pouco simbolizada e temporalmente próxima do início do medicamento. Também convém considerar cafeína, outros estimulantes, privação de sono e estressores recentes antes de atribuir a mudança ao remédio.

Sono: Insônia inicial, sono fragmentado ou, em parte dos pacientes, sonolência e sensação de cansaço podem alterar o padrão da sessão e a capacidade de elaboração. O terapeuta pode encontrar mais fadiga, menor tolerância à frustração, dificuldade de concentração ou irritabilidade, o que tanto pode decorrer do medicamento quanto da própria depressão, de ansiedade noturna ou de rotina desorganizada. A discriminação melhora quando se observa a relação temporal entre início do uso, mudança no sono e oscilação do funcionamento diurno.

Sexualidade: Redução de desejo, dificuldade de excitação ou atraso para atingir orgasmo podem surgir e muitas vezes não aparecem espontaneamente, embora afetem vínculo, autoestima e adesão. Em sessão, isso pode ser confundido com distanciamento afetivo do parceiro, conflito conjugal, humor deprimido residual ou vergonha corporal. Quando a mudança sexual coincide com o início do tratamento e contrasta com o padrão anterior, vale registrar porque esse é um motivo frequente de abandono silencioso.

Adesão e descontinuação: Esquecimentos, pausas de alguns dias, uso irregular em fins de semana ou interrupção por conta própria podem produzir mal-estar, irritabilidade, tontura, sensação de instabilidade e piora subjetiva abrupta. Na sessão, esse quadro às vezes parece recaída depressiva ou aumento de ansiedade, mas a pista costuma estar na cronologia curta e no caráter mais corporal e súbito da mudança. Como muitos pacientes omitem falhas por vergonha ou por acharem que “não faz diferença”, perguntas diretas e não moralizantes ajudam a leitura clínica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A desvenlafaxina é um antidepressivo usado sobretudo em quadros depressivos e, em alguns casos, quando há ansiedade associada. No consultório, as primeiras 1 a 2 semanas costumam ser o período em que mais aparecem oscilação entre náusea, ativação, piora subjetiva da ansiedade, insônia ou sonolência e dúvidas sobre continuidade; sinais de benefício tendem a ficar mais claros entre 2 e 6 semanas, às vezes com melhora funcional antes de uma mudança afetiva mais nítida. Se houver interrupção abrupta ou uso irregular, nos dias seguintes podem surgir mal-estar, tontura, irritabilidade e sensação de “estranheza”, o que pode se confundir com recaída. O ponto central na sessão é diferenciar ativação inicial, resposta parcial, embotamento e descontinuação de mudanças do próprio quadro.

Perguntas úteis

- "Quando essa inquietação apareceu, ela veio junto de pensamentos e preocupações reconhecíveis ou mais como uma tensão no corpo sem um tema claro? , Você percebe que está melhor porque sofre menos e se sente mais conectado, ou principalmente porque está conseguindo funcionar e cumprir tarefas? , Essa mudança no sono começou perto do início do medicamento ou acompanha uma fase de mais ruminação, estresse ou mudança de rotina? , Na sexualidade, a dificuldade parece mais ligada ao vínculo e ao desejo pelo parceiro ou ao funcionamento do corpo ter mudado apesar de o interesse afetivo continuar? , Quando houve piora mais brusca, isso aconteceu depois de esquecer, atrasar ou interromper o uso por alguns dias, ou pareceu surgir mesmo mantendo a rotina habitual? , Esse aumento de energia veio com mais clareza e organização, ou com menos necessidade de dormir, impulsividade e sensação de estar acelerado além do seu padrão?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve piora importante de ansiedade
- agitação ou insônia nas primeiras semanas
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar a intensidade da mudança e o impacto na continuidade do tratamento
- Quando surgem dificuldades sexuais persistentes que afetam vínculo
- autoestima ou favorecem abandono silencioso
- pode valer comunicar o médico assistente pela repercussão direta na adesão
- Quando há uso irregular
- interrupções por conta própria ou pioras abruptas após esquecimentos
- pode valer alinhar com o psiquiatra para esclarecer se o quadro acompanha descontinuação ou outra evolução clínica
- Quando
- após cerca de 4 a 6 semanas de uso regular
- não se observa ganho funcional nem redução do sofrimento
- pode valer comunicar o médico assistente pela ausência de resposta perceptível no acompanhamento

Amarelo: alinhar em breve

- Quando aparece aumento de energia com redução importante do sono
- impulsividade
- expansividade ou irritabilidade fora do padrão
- pode valer alinhar com o psiquiatra pela possibilidade de mudança de polaridade do humor

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a falar em morte
- desesperança extrema ou intenção de se ferir com aumento de energia para agir.: Fazer avaliação de risco no mesmo atendimento e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente chega muito acelerado
- dormindo muito menos
- com grandiosidade
- impulsividade ou comportamento claramente fora do seu padrão habitual.: Registrar a mudança observável e buscar contato no mesmo dia com o psiquiatra; se houver risco comportamental
- acionar também rede de apoio e urgência

Frase clínica

O foco é separar ativação inicial, resposta parcial e descontinuação de uma piora real do quadro ou de mudanças ligadas à vida do paciente.

119 AGOMELATINA

Substância: Agomelatina.

Nomes Comerciais: Agomelatina, Valdoxan, Agoxom, Elencos

Uso comum

- Agomelatina é um antidepressivo usado sobretudo em episódios depressivos, às vezes escolhido quando sono e ritmo circadiano estão muito desorganizados. No consultório, a observação costuma se concentrar nas primeiras 2 a 4 semanas, quando o paciente pode notar mudança no padrão de sono, energia matinal e reatividade afetiva antes de uma melhora mais consistente do humor; em torno de 4 a 8 semanas já costuma ser possível avaliar se houve ganho clínico perceptível. O ponto central na sessão é diferenciar reorganização do sono e leve retomada de energia de melhora depressiva mais ampla, além de notar interrupções silenciosas do uso e sinais físicos inespecíficos que mudam o padrão habitual do paciente.

O paciente pode relatar

- **"Sono e ritmo:** Alguns pacientes chegam relatando adormecer com mais facilidade, sono menos fragmentado ou sensação de ritmo mais regular, e isso pode aparecer na sessão como maior presença, menos exaustão e melhor encadeamento associativo. Ainda assim, sono melhor não equivale necessariamente a remissão depressiva: às vezes o humor segue baixo, com anedonia e autocrítica preservadas. Também vale considerar mudanças de rotina, redução de estressores, higiene do sono mais consistente ou uso irregular da medicação quando o padrão melhora e piora sem muita coerência.

Energia matinal: Pode surgir uma retomada discreta de energia, especialmente no início do dia, com menos lentificação e mais capacidade de engajar na sessão. Isso pode ser confundido tanto com melhora global do episódio depressivo quanto com um alívio parcial restrito ao cansaço e ao sono. Quando a energia oscila muito entre sessões, convém explorar se houve noites diferentes, eventos de vida recentes ou uso não contínuo, em vez de atribuir a mudança a um único fator.

Humor e anedonia: Ao longo de algumas semanas, o terapeuta pode observar menos desesperança, maior acesso afetivo e alguma volta de interesse por atividades antes abandonadas. A leitura fica mais complexa quando o paciente descreve estar "menos mal", mas ainda sem prazer, iniciativa ou perspectiva, quadro que pode refletir melhora parcial, adaptação a circunstâncias externas ou flutuação natural do episódio. O contraste entre o que ele relata fora da sessão e o que se observa no encontro ajuda a discriminar se houve mudança de baseline ou apenas um dia melhor.

Tolerabilidade inicial: No começo do uso, podem aparecer desconfortos inespecíficos como mal-estar, náusea, cefaleia ou sensação corporal de estranhamento, às vezes suficientes para reduzir espontaneamente a adesão sem que o paciente nomeie isso de imediato. Na sessão, isso pode surgir como irritabilidade com o tratamento, menor disponibilidade psíquica ou foco excessivo no corpo. Como sintomas semelhantes também acompanham ansiedade, piora do sono, viroses e sobrecarga cotidiana, vale mapear temporalidade e impacto funcional antes de concluir que se trata do medicamento.

Adesão e interrupção: Por não produzir uma mudança subjetiva dramática logo de início, a agomelatina pode ser usada de modo irregular ou interrompida sem muita elaboração, especialmente quando o paciente entende a melhora do sono como suficiente ou, ao contrário, não percebe benefício rápido. O terapeuta pode notar isso quando o relato fica inconsistente, com avanços e recuos abruptos no sono e na energia sem correspondência clara com eventos de vida. Nesses casos, a discriminação clínica depende menos de interpretar o conteúdo e mais de reconstruir a sequência concreta dos dias e do uso.

Sinais físicos relevantes: Embora a maior parte do acompanhamento em terapia permaneça no campo subjetivo, vale atenção quando surgem cansaço incomum, mal-estar persistente, náusea importante, dor abdominal, urina escura ou coloração amarelada da pele e dos olhos, sobretudo se isso foge claramente do padrão do paciente. Esses achados podem ser confundidos com infecção, alimentação, uso de álcool ou outras medicações, mas merecem registro cuidadoso porque mudam o enquadre da sessão. Aqui o papel do terapeuta é

reconhecer a mudança, verificar impacto e urgência, e não normalizar um quadro físico novo."

O que observar em sessão

- **Sono e ritmo:** Alguns pacientes chegam relatando adormecer com mais facilidade, sono menos fragmentado ou sensação de ritmo mais regular, e isso pode aparecer na sessão como maior presença, menos exaustão e melhor encadeamento associativo. Ainda assim, sono melhor não equivale necessariamente a remissão depressiva: às vezes o humor segue baixo, com anedonia e autocrítica preservadas. Também vale considerar mudanças de rotina, redução de estressores, higiene do sono mais consistente ou uso irregular da medicação quando o padrão melhora e piora sem muita coerência.

Energia matinal: Pode surgir uma retomada discreta de energia, especialmente no início do dia, com menos lentificação e mais capacidade de engajar na sessão. Isso pode ser confundido tanto com melhora global do episódio depressivo quanto com um alívio parcial restrito ao cansaço e ao sono. Quando a energia oscila muito entre sessões, convém explorar se houve noites diferentes, eventos de vida recentes ou uso não contínuo, em vez de atribuir a mudança a um único fator.

Humor e anedonia: Ao longo de algumas semanas, o terapeuta pode observar menos desesperança, maior acesso afetivo e alguma volta de interesse por atividades antes abandonadas. A leitura fica mais complexa quando o paciente descreve estar “menos mal”, mas ainda sem prazer, iniciativa ou perspectiva, quadro que pode refletir melhora parcial, adaptação a circunstâncias externas ou flutuação natural do episódio. O contraste entre o que ele relata fora da sessão e o que se observa no encontro ajuda a discriminar se houve mudança de baseline ou apenas um dia melhor.

Tolerabilidade inicial: No começo do uso, podem aparecer desconfortos inespecíficos como mal-estar, náusea, cefaleia ou sensação corporal de estranhamento, às vezes suficientes para reduzir espontaneamente a adesão sem que o paciente nomeie isso de imediato. Na sessão, isso pode surgir como irritabilidade com o tratamento, menor disponibilidade psíquica ou foco excessivo no corpo. Como sintomas semelhantes também acompanham ansiedade, piora do sono, viroses e sobrecarga cotidiana, vale mapear temporalidade e impacto funcional antes de concluir que se trata do medicamento.

Adesão e interrupção: Por não produzir uma mudança subjetiva dramática logo de início, a agomelatina pode ser usada de modo irregular ou interrompida sem muita elaboração, especialmente quando o paciente entende a melhora do sono como suficiente ou, ao contrário, não percebe benefício rápido. O terapeuta pode notar isso quando o relato fica inconsistente, com avanços e recuos abruptos no sono e na energia sem correspondência clara com eventos de vida. Nesses casos, a discriminação clínica depende menos de interpretar o conteúdo e mais de reconstruir a sequência concreta dos dias e do uso.

Sinais físicos relevantes: Embora a maior parte do acompanhamento em terapia permaneça no campo subjetivo, vale atenção quando surgem cansaço incomum, mal-estar persistente, náusea importante, dor abdominal, urina escura ou coloração amarelada da pele e dos olhos, sobretudo se isso foge claramente do padrão do paciente. Esses achados podem ser confundidos com infecção, alimentação, uso de álcool ou outras medicações, mas merecem registro cuidadoso porque mudam o enquadre da sessão. Aqui o papel do terapeuta é

reconhecer a mudança, verificar impacto e urgência, e não normalizar um quadro físico novo.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Agomelatina é um antidepressivo usado sobretudo em episódios depressivos, às vezes escolhido quando sono e ritmo circadiano estão muito desorganizados. No consultório, a observação costuma se concentrar nas primeiras 2 a 4 semanas, quando o paciente pode notar mudança no padrão de sono, energia matinal e reatividade afetiva antes de uma melhora mais consistente do humor; em torno de 4 a 8 semanas já costuma ser possível avaliar se houve ganho clínico perceptível. O ponto central na sessão é diferenciar reorganização do sono e leve retomada de energia de melhora depressiva mais ampla, além de notar interrupções silenciosas do uso e sinais físicos inespecíficos que mudam o padrão habitual do paciente.

Perguntas úteis

- "Quando seu sono melhorou, isso veio junto com mais interesse pelas coisas e mais capacidade de se envolver com a vida, ou ficou mais restrito a dormir melhor? , Nos dias em que você se sente com mais energia pela manhã, isso se mantém ao longo do dia ou desaparece rápido e o humor continua pesado? , Essa oscilação que você percebe começou depois de alguma mudança concreta na rotina ou apareceu mesmo com os dias parecidos entre si? , Quando você diz que está 'menos mal', o que exatamente voltou a acontecer na prática que antes não acontecia? , Teve dias em que você deixou de tomar, tomou em horários muito diferentes ou pensou em parar porque não estava vendo sentido ou porque se sentiu mal? , Esse mal-estar corporal apareceu junto de ansiedade e noites ruins, ou pareceu algo físico novo, diferente do que costuma acontecer com você?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve uso irregular
- interrupção por conta própria ou abandono silencioso por não perceber benefício inicial
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a leitura clínica da resposta e da adesão
- Quando após 4 a 8 semanas não se observa melhora minimamente consistente de humor
- anedonia ou funcionamento
- apesar de algum ajuste no sono
- pode valer comunicar o médico para reavaliar a evolução do quadro
- Quando surgem náusea persistente
- mal-estar importante
- dor abdominal
- urina escura ou coloração amarelada da pele ou dos olhos
- pode valer contato mais breve com o médico pela necessidade de avaliação clínica
- Quando aparece aceleração incomum
- redução importante da necessidade de sono

Amarelo: alinhar em breve

- expansividade ou irritabilidade fora do padrão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para diferenciar melhora de humor de possível virada de polaridade
- Quando a melhora do sono convive com piora de desesperança
- retraimento ou ideação suicida
- a comunicação com o médico assistente ganha relevância por mudança de risco em contexto de tratamento em curso

Vermelho: tratar como urgência

- Surge ideação suicida nova ou claramente intensificada
- sobretudo nas primeiras semanas
- com piora de desesperança
- agitação ou retraimento acentuado.: Avaliar risco imediatamente
- acionar psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhar para emergência quando necessário
- O paciente aparece com redução marcante da necessidade de sono
- fala acelerada
- aumento incomum de impulsividade
- grandiosidade ou irritabilidade fora do baseline.: Tratar como mudança aguda de estado
- contatar o psiquiatra no mesmo dia e ampliar medidas de proteção conforme o risco
- Na sessão ou no contato próximo
- surgem mal-estar físico importante com náusea persistente
- dor abdominal
- urina escura ou aspecto amarelado da pele ou dos olhos.: Orientar busca de avaliação médica no mesmo dia e
- se possível
- comunicar o médico assistente pela mudança física relevante

Frase clínica

O foco é distinguir melhora do sono e da energia matinal de resposta antidepressiva mais ampla, sem perder sinais físicos novos e adesão irregular.

120 BROMIDRATO DE VORTIOXETINA

Substância: Bromidrato de Vortioxetina.

Nomes Comerciais: Voextor, Bromidrato de Vortioxetina, Vod, Vognus, Vorse, Brintellix, Vurtuoso, Vorpro, Môdulix, Evortia

Uso comum

- A vortioxetina é um antidepressivo usado sobretudo em episódios depressivos, às vezes escolhida quando queixas cognitivas e funcionamento diário ocupam lugar importante no quadro. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta pode encontrar oscilação entre leve ativação, desconfortos físicos e pouca mudança subjetiva; sinais de resposta costumam ficar mais nítidos entre 2 e 6 semanas, com consolidação ao longo das semanas seguintes. Na sessão, o ponto central é diferenciar melhora depressiva real de uma adaptação ainda instável, observando energia, acesso afetivo, clareza cognitiva, sexualidade e adesão silenciosamente irregular.

O paciente pode relatar

- **"Humor e reatividade:** Ao longo das primeiras semanas, o paciente pode descrever menos peso depressivo sem recuperar na mesma velocidade interesse, prazer ou capacidade de se implicar na própria vida. Em sessão, vale observar se há ampliação genuína da faixa afetiva e da responsividade emocional ou apenas uma redução do sofrimento mais agudo. Essa leitura pode se confundir tanto com melhora parcial do episódio quanto com alívio por eventos externos favoráveis, e também com uso irregular que produz uma evolução em zigue-zague.

Cognição funcional: Alguns pacientes chamam atenção menos por tristeza explícita e mais por dificuldade de concentração, lentificação para pensar, sensação de mente enevoada ou menor fluidez verbal, e isso pode ser um eixo importante de acompanhamento com vortioxetina. Na sessão, interessa notar se a narrativa fica mais organizada, se o paciente sustenta melhor encadeamento e memória recente, ou se a queixa cognitiva permanece apesar de alguma melhora do humor. Fadiga, privação de sono, ansiedade elevada e sobrecarga de vida podem produzir quadro semelhante, de modo que a discriminação depende de comparar com a baseline e com a rotina entre sessões.

Ativação e ansiedade inicial: No início do uso, parte dos pacientes pode chegar mais inquieta, impaciente ou com sensação de aceleração subjetiva, sem que isso signifique necessariamente piora estrutural do quadro. O terapeuta pode perceber fala um pouco mais rápida, menor tolerância a pausas ou aumento de tensão corporal, mas precisa diferenciar isso de ansiedade habitual, estresse situacional ou traços de funcionamento já presentes antes. Quando a ativação aparece junto de redução importante do sono, expansividade ou condutas fora do padrão, a hipótese clínica muda e merece observação mais estreita.

Tolerabilidade inicial: Náusea e mal-estar inespecífico nas primeiras semanas podem ocupar bastante espaço no relato e, às vezes, reduzir disponibilidade psíquica para o trabalho terapêutico. Em sessão, isso pode aparecer como menor paciência, mais foco no corpo, dificuldade de associação e irritabilidade secundária ao desconforto. Como sintomas físicos também acompanham ansiedade, viroses, alimentação irregular e outras medicações, vale situar temporalmente o início, a flutuação ao longo dos dias e o impacto real na adesão.

Sexualidade: Mesmo quando o humor melhora, podem surgir mudanças em desejo, excitação ou orgasmo que o paciente nem sempre traz espontaneamente, sobretudo se houver vergonha ou receio de parecer superficial. Na clínica, isso pode aparecer como afastamento do parceiro, queda de iniciativa íntima ou sensação de estranhamento com o próprio corpo, o que pode ser confundido com conflito relacional, depressão residual ou retraimento afetivo. A utilidade do tema está menos em atribuir causa e mais em detectar um fator que favorece sofrimento silencioso e abandono do tratamento.

Adesão e descontinuação: Com antidepressivos, não é raro que o paciente altere o uso por conta própria quando sente pouca melhora inicial, desconfortos físicos ou ambivalência em relação a estar medicado. Na sessão, isso costuma aparecer como narrativa inconsistente sobre a evolução, melhora que não se sustenta, retorno abrupto de sintomas ou dificuldade de nomear desde quando algo mudou. A leitura pode se confundir com recaída, flutuação natural do episódio depressivo ou impacto de eventos de vida, por isso perguntas temporais simples

costumam ser mais úteis do que interpretações rápidas."

O que observar em sessão

- **Humor e reatividade:** Ao longo das primeiras semanas, o paciente pode descrever menos peso depressivo sem recuperar na mesma velocidade interesse, prazer ou capacidade de se implicar na própria vida. Em sessão, vale observar se há ampliação genuína da faixa afetiva e da responsividade emocional ou apenas uma redução do sofrimento mais agudo. Essa leitura pode se confundir tanto com melhora parcial do episódio quanto com alívio por eventos externos favoráveis, e também com uso irregular que produz uma evolução em zigue-zague.

Cognição funcional: Alguns pacientes chamam atenção menos por tristeza explícita e mais por dificuldade de concentração, lentificação para pensar, sensação de mente enevoada ou menor fluidez verbal, e isso pode ser um eixo importante de acompanhamento com vortioxetina. Na sessão, interessa notar se a narrativa fica mais organizada, se o paciente sustenta melhor encadeamento e memória recente, ou se a queixa cognitiva permanece apesar de alguma melhora do humor. Fadiga, privação de sono, ansiedade elevada e sobrecarga de vida podem produzir quadro semelhante, de modo que a discriminação depende de comparar com a baseline e com a rotina entre sessões.

Ativação e ansiedade inicial: No início do uso, parte dos pacientes pode chegar mais inquieta, impaciente ou com sensação de aceleração subjetiva, sem que isso signifique necessariamente piora estrutural do quadro. O terapeuta pode perceber fala um pouco mais rápida, menor tolerância a pausas ou aumento de tensão corporal, mas precisa diferenciar isso de ansiedade habitual, estresse situacional ou traços de funcionamento já presentes antes. Quando a ativação aparece junto de redução importante do sono, expansividade ou condutas fora do padrão, a hipótese clínica muda e merece observação mais estreita.

Tolerabilidade inicial: Náusea e mal-estar inespecífico nas primeiras semanas podem ocupar bastante espaço no relato e, às vezes, reduzir disponibilidade psíquica para o trabalho terapêutico. Em sessão, isso pode aparecer como menor paciência, mais foco no corpo, dificuldade de associação e irritabilidade secundária ao desconforto. Como sintomas físicos também acompanham ansiedade, viroses, alimentação irregular e outras medicações, vale situar temporalmente o início, a flutuação ao longo dos dias e o impacto real na adesão.

Sexualidade: Mesmo quando o humor melhora, podem surgir mudanças em desejo, excitação ou orgasmo que o paciente nem sempre traz espontaneamente, sobretudo se houver vergonha ou receio de parecer superficial. Na clínica, isso pode aparecer como afastamento do parceiro, queda de iniciativa íntima ou sensação de estranhamento com o próprio corpo, o que pode ser confundido com conflito relacional, depressão residual ou retraimento afetivo. A utilidade do tema está menos em atribuir causa e mais em detectar um fator que favorece sofrimento silencioso e abandono do tratamento.

Adesão e descontinuação: Com antidepressivos, não é raro que o paciente altere o uso por conta própria quando sente pouca melhora inicial, desconfortos físicos ou ambivalência em relação a estar medicado. Na sessão, isso costuma aparecer como narrativa inconsistente sobre a evolução, melhora que não se sustenta, retorno abrupto de sintomas ou dificuldade de nomear desde quando algo mudou. A leitura pode se confundir com recaída, flutuação natural do episódio depressivo ou impacto de eventos de vida, por isso perguntas temporais simples

costumam ser mais úteis do que interpretações rápidas.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A vortioxetina é um antidepressivo usado sobretudo em episódios depressivos, às vezes escolhida quando queixas cognitivas e funcionamento diário ocupam lugar importante no quadro. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta pode encontrar oscilação entre leve ativação, desconfortos físicos e pouca mudança subjetiva; sinais de resposta costumam ficar mais nítidos entre 2 e 6 semanas, com consolidação ao longo das semanas seguintes. Na sessão, o ponto central é diferenciar melhora depressiva real de uma adaptação ainda instável, observando energia, acesso afetivo, clareza cognitiva, sexualidade e adesão silenciosamente irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está melhor, isso aparece como mais interesse e envolvimento com a vida ou mais como um alívio do peso sem recuperar vontade e prazer? , Essa inquietação que surgiu se parece com a sua ansiedade de costume ou tem um componente mais corporal, como se fosse difícil ficar parado mesmo quando a cabeça não está tão preocupada? , A dificuldade de concentração vem junto com tristeza e desânimo, ou persiste mesmo em dias em que o humor parece um pouco melhor? , Na sua vida íntima, a mudança foi mais de desejo e resposta do corpo ou de interesse afetivo pelo parceiro e pela relação? , Essas oscilações da semana aconteceram apesar de você manter o uso de forma estável, ou houve dias em que pulou, atrasou ou interrompeu por conta do que estava sentindo? , Desde que começou a medicação, você está dormindo menos porque não consegue desligar e fica mais acelerado, ou dorme menos por preocupação e ruminação como já acontecia antes?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente mostra pouca ou nenhuma mudança clínica após cerca de 4 a 6 semanas
- apesar de adesão aparentemente consistente
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar a evolução do quadro e a persistência de sintomas-alvo
- Quando náusea
- mal-estar ou desconforto corporal passam a interferir no trabalho
- na alimentação ou favorecem faltas e uso irregular
- pode valer comunicar o médico assistente pela repercussão funcional e risco de abandono silencioso
- Quando surgem queixas sexuais novas ou claramente intensificadas e isso começa a afetar vínculo
- autoestima ou adesão
- pode valer alinhar com o psiquiatra para que esse fator entre na leitura global do tratamento
- Quando a sessão sugere uso intermitente
- interrupções por conta própria ou retomadas irregulares

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicar o médico assistente porque a evolução clínica fica difícil de interpretar e o paciente pode estar oscilando entre efeito
- descontinuação e quadro de base
- Quando aparecem redução importante da necessidade de sono
- aceleração incomum
- expansividade ou impulsividade fora da linha de base
- pode valer contato com o psiquiatra para discutir possível mudança de polaridade ou ativação clinicamente relevante

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a falar em morte
- desesperança intensa ou intenção de se ferir de modo mais nítido do que na linha de base.: Fazer avaliação de risco na hora e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente chega muito acelerado
- dormindo muito menos sem cansaço
- mais expansivo ou irritável
- com ideias grandiosas ou condutas claramente fora do padrão habitual.: Registrar a mudança de estado e buscar contato no mesmo dia com o psiquiatra; se houver risco comportamental
- acionar também rede de apoio e avaliação de urgência

Frase clínica

Na terapia, o foco com vortioxetina é distinguir melhora depressiva real de adaptação ainda instável, com atenção a cognição, ativação inicial e adesão.

121 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA

Substância: Cloridrato de Amitriptilina.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Amitriptilina, Amytril, Mitrip

Uso comum

- A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico que pode aparecer no consultório em depressão, quadros ansiosos com insônia, dor crônica e cefaleias, às vezes em doses baixas com alvo principal no sono ou na dor. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta costuma acompanhar mais de perto sedação, lentificação, boca seca e dificuldade de concentração; mudanças de humor e ansiedade podem levar algumas semanas para se definir com mais clareza, em geral entre 2 e 6 semanas. O ponto central na sessão é diferenciar melhora por maior repouso e redução da dor de um embotamento ou cansaço medicamentoso que empobrece o trabalho terapêutico, além de notar adesão irregular quando o paciente ajusta o uso por conta própria para escapar da sonolência.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Sonolência, fala mais lenta, dificuldade para sustentar atenção e sensação de "ressaca" ao longo do dia podem aparecer cedo e alterar o ritmo habitual da sessão. Isso pode ser confundido com piora depressiva, privação de sono prévia ou exaustão por dor crônica. Vale comparar com a baseline: o paciente chega mais sonolento em horários específicos, perde o fio com mais facilidade ou parece globalmente menos acessível do que antes do início do uso?

Sono e repouso: Em parte dos pacientes, o sono fica mais fácil de iniciar ou mais contínuo, e isso pode produzir alívio subjetivo rápido, com mais tolerância emocional e menos irritabilidade na sessão. Ao mesmo tempo, dormir mais não equivale necessariamente a melhora do humor de base, e o terapeuta pode encontrar um paciente menos sofrido, porém ainda pouco engajado, anedônico ou sem perspectiva. Quando há dor, a melhora do repouso também pode reduzir sofrimento sem que o quadro depressivo tenha mudado na mesma proporção.

Humor e acesso afetivo: Ao longo de algumas semanas, pode surgir redução de desesperança, choro e ruminação, mas também um achatamento subjetivo em que o paciente descreve estar "menos mal" sem recuperar vitalidade psíquica. Na sessão, isso pode se parecer tanto com resposta parcial quanto com embotamento que empobrece elaboração e contato com afetos. Eventos de vida favoráveis, melhora do sono ou oscilação natural do episódio podem confundir essa leitura, por isso ajuda observar se houve retomada de interesse, iniciativa e amplitude emocional, e não apenas queda da intensidade do sofrimento.

Cognição e anticolinérgicos: Boca seca, constipação, visão turva e sensação de cabeça "pesada" às vezes aparecem junto de queixas de memória recente, lentificação e dificuldade para organizar pensamento. No consultório, isso pode ser percebido como maior esforço para acompanhar interpretações, esquecer temas combinados ou perder encadeamento narrativo. Como depressão, ansiedade elevada, dor e noites ruins também afetam cognição, a discriminação depende de notar a proximidade temporal com o início do medicamento e se a oscilação acompanha mais o corpo cansado do que o conteúdo emocional.

Adesão silenciosa: Amitriptilina frequentemente produz efeitos incômodos o bastante para o paciente começar a pular tomadas, mudar horários por conta própria ou manter uso irregular sem nomear isso espontaneamente. Na terapia, isso pode aparecer como oscilação pouco explicável entre sessões, com dias de muito sono e outros de piora abrupta do humor, da dor ou da irritabilidade. Quando o padrão fica serrilhado demais para ser entendido apenas por eventos de vida, vale considerar adesão irregular como hipótese clínica a ser explorada com cuidado.

Virada de humor: Embora seja usada como antidepressivo, em pacientes com vulnerabilidade bipolar pode coincidir com aceleração importante: menos necessidade de sono, fala pressionada, expansividade, irritação incomum, impulsividade ou sensação de clareza excessiva. Na sessão, isso pode ser confundido com "finalmente estou melhor", sobretudo se vier após semanas de apatia. O ponto discriminativo é a mudança de qualidade do funcionamento: não apenas menos tristeza, mas aumento de velocidade, desinibição e perda de freios em relação à linha de base."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Sonolência, fala mais lenta, dificuldade para sustentar atenção e sensação de “ressaca” ao longo do dia podem aparecer cedo e alterar o ritmo habitual da sessão. Isso pode ser confundido com piora depressiva, privação de sono prévia ou exaustão por dor crônica. Vale comparar com a baseline: o paciente chega mais sonolento em horários específicos, perde o fio com mais facilidade ou parece globalmente menos acessível do que antes do início do uso?

Sono e repouso: Em parte dos pacientes, o sono fica mais fácil de iniciar ou mais contínuo, e isso pode produzir alívio subjetivo rápido, com mais tolerância emocional e menos irritabilidade na sessão. Ao mesmo tempo, dormir mais não equivale necessariamente a melhora do humor de base, e o terapeuta pode encontrar um paciente menos sofrido, porém ainda pouco engajado, anedônico ou sem perspectiva. Quando há dor, a melhora do repouso também pode reduzir sofrimento sem que o quadro depressivo tenha mudado na mesma proporção.

Humor e acesso afetivo: Ao longo de algumas semanas, pode surgir redução de desesperança, choro e ruminação, mas também um achatamento subjetivo em que o paciente descreve estar “menos mal” sem recuperar vitalidade psíquica. Na sessão, isso pode se parecer tanto com resposta parcial quanto com embotamento que empobrece elaboração e contato com afetos. Eventos de vida favoráveis, melhora do sono ou oscilação natural do episódio podem confundir essa leitura, por isso ajuda observar se houve retomada de interesse, iniciativa e amplitude emocional, e não apenas queda da intensidade do sofrimento.

Cognição e anticolinérgicos: Boca seca, constipação, visão turva e sensação de cabeça “pesada” às vezes aparecem junto de queixas de memória recente, lentificação e dificuldade para organizar pensamento. No consultório, isso pode ser percebido como maior esforço para acompanhar interpretações, esquecer temas combinados ou perder encadeamento narrativo. Como depressão, ansiedade elevada, dor e noites ruins também afetam cognição, a discriminação depende de notar a proximidade temporal com o início do medicamento e se a oscilação acompanha mais o corpo cansado do que o conteúdo emocional.

Adesão silenciosa: Amitriptilina frequentemente produz efeitos incômodos o bastante para o paciente começar a pular tomadas, mudar horários por conta própria ou manter uso irregular sem nomear isso espontaneamente. Na terapia, isso pode aparecer como oscilação pouco explicável entre sessões, com dias de muito sono e outros de piora abrupta do humor, da dor ou da irritabilidade. Quando o padrão fica serrilhado demais para ser entendido apenas por eventos de vida, vale considerar adesão irregular como hipótese clínica a ser explorada com cuidado.

Virada de humor: Embora seja usada como antidepressivo, em pacientes com vulnerabilidade bipolar pode coincidir com aceleração importante: menos necessidade de sono, fala pressionada, expansividade, irritação incomum, impulsividade ou sensação de clareza excessiva. Na sessão, isso pode ser confundido com “finalmente estou melhor”, sobretudo se vier após semanas de apatia. O ponto discriminativo é a mudança de qualidade do funcionamento: não apenas menos tristeza, mas aumento de velocidade, desinibição e perda de freios em relação à linha de base.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico que pode aparecer no consultório em depressão, quadros ansiosos com insônia, dor crônica e cefaleias, às vezes em doses baixas com alvo principal no sono ou na dor. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta costuma acompanhar mais de perto sedação, lentificação, boca seca e dificuldade de concentração; mudanças de humor e ansiedade podem levar algumas semanas para se definir com mais clareza, em geral entre 2 e 6 semanas. O ponto central na sessão é diferenciar melhora por maior repouso e redução da dor de um embotamento ou cansaço medicamentoso que empobrece o trabalho terapêutico, além de notar adesão irregular quando o paciente ajusta o uso por conta própria para escapar da sonolência.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está melhor, essa melhora vem com mais disposição para viver o dia ou mais como um amortecimento em que você sofre menos, mas também sente menos? , Nos dias em que você chega mais lento ou sonolento, isso parece uma tristeza pesada como antes ou um cansaço corporal e mental que piora em certos horários? , Seu sono melhorou de um jeito que te deixa mais restaurado durante o dia, ou você sente que dorme mais mas acorda arrastado e menos nítido? , Essas oscilações entre uma sessão e outra combinam mais com acontecimentos da semana ou com dias em que você acabou mudando, esquecendo ou evitando o remédio por causa dos efeitos? , Essa fase de mais energia veio junto de maior clareza e organização, ou junto de pressa, menos sono, irritação e atitudes que não são seu padrão? , A dificuldade de concentração aparece mais quando o assunto te mobiliza emocionalmente ou mesmo em momentos neutros, como se sua cabeça estivesse mais lenta no geral?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente mantém sonolência
- lentificação ou prejuízo cognitivo que passam a comprometer trabalho
- direção
- cuidado com filhos ou o próprio processo terapêutico
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar impacto funcional e tolerabilidade
- Quando surgem sinais de possível aceleração do humor após o início do uso
- como redução importante da necessidade de sono
- fala muito aumentada
- irritabilidade ou impulsividade fora do padrão
- pode valer comunicar o psiquiatra para reavaliar o quadro
- Quando o paciente passa a usar de modo irregular ou admite que vem evitando o medicamento por conta de boca seca
- constipação
- sedação ou sensação de cabeça pesada
- pode valer contato com o médico para prevenir abandono silencioso e leitura equivocada de resposta

Amarelo: alinhar em breve

- Quando não há mudança clínica perceptível após cerca de 4 a 6 semanas de uso regular
- pode valer alinhar com o médico assistente para registrar ausência de resposta observável no consultório
- Quando aparecem palpitações
- tontura importante
- quase desmaio ou quedas em associação temporal com o uso
- pode valer comunicação mais breve com o médico pela relevância clínica desses sinais

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente apresenta ideação suicida emergente ou claramente intensificada
- sobretudo nas primeiras semanas
- com piora de agitação
- desesperança ou impulsividade.: Avalie risco no mesmo atendimento
- acione psiquiatra e rede de apoio hoje e encaminhe para emergência quando houver risco iminente
- Surge mudança abrupta para muito menos sono
- fala acelerada
- grandiosidade
- irritação marcada ou condutas impulsivas que destoam nitidamente da linha de base.: Considere urgência clínica
- contate o psiquiatra no mesmo dia e mobilize rede de apoio se houver prejuízo de juízo crítico ou risco comportamental
- O paciente chega confuso
- muito sonolento
- cambaleante
- com fala arrastada importante
- ou relata desmaio
- queda ou palpitações intensas recentes.: Interrompa o foco psicoterápico
- avalie segurança imediata e encaminhe para avaliação médica urgente ou emergência conforme gravidade

Frase clínica

O foco clínico é separar melhora por sono e alívio da dor de sedação, lentificação e adesão irregular que distorcem a leitura da sessão.

122 CLORIDRATO DE BUPROPIONA

Substância: Cloridrato de Bupropiona.

Nomes Comerciais: Zetron, Bup, Cloridrato de Bupropiona, Bup XI, Wellbutrin, Buene, Alpes XI, Seth, Buprexix XI, Eutymia XI, Deradop XI, Noradop, Bupium XI, Bupium

Uso comum

- A bupropiona é um antidepressivo atípico que costuma aparecer em quadros depressivos, cessação do tabagismo e, em alguns pacientes, como estratégia quando há queixa sexual com outros antidepressivos. No consultório, o ponto central é acompanhar se a ativação inicial se traduz em mais energia útil ou em piora de ansiedade, irritabilidade e sono. Nas primeiras 1 a 3 semanas podem surgir inquietação, insônia ou sensação de aceleração antes de uma melhora mais consistente do humor, que tende a ficar mais clara ao longo de 4 a 6 semanas. Também vale observar adesão irregular, já que interrupções e retomadas podem confundir a leitura da evolução clínica.

O paciente pode relatar

- **"Ativação inicial:** No início, alguns pacientes chegam mais ligados, falantes, com sensação de energia aumentada ou urgência para agir. Em parte dos casos isso acompanha uma retomada funcional; em outros, vem junto de inquietação, irritabilidade ou sensação corporal de aceleração que não combina com melhora subjetiva do humor. A leitura pode se confundir com alívio por eventos de vida, com traços habituais de ansiedade ou com uso irregular, especialmente quando o paciente descreve dias muito diferentes entre si sem mudança externa correspondente.

Ansiedade e irritabilidade: A sessão pode mostrar menor lentificação, mas maior reatividade, impaciência e tolerância reduzida à frustração. Isso pode ser lido apressadamente como piora global do quadro, quando às vezes se trata de uma ativação desconfortável no começo do uso; em outros casos, a irritabilidade já fazia parte da depressão ou de conflitos atuais e apenas ficou mais visível com menos apatia. Vale observar se a tensão aparece como algo novo na linha de base, se tem horário mais marcado e se o paciente a associa ao período após iniciar ou retomar a medicação.

Sono: Insônia inicial, sono mais leve ou dificuldade para desacelerar à noite podem aparecer cedo e impactar a sessão por cansaço, menor tolerância afetiva e pior capacidade de elaboração. O risco clínico é atribuir tudo à depressão ou à ansiedade de base sem notar que a piora do sono começou junto com a medicação ou após adesão irregular. Quando o paciente já vinha dormindo mal, a discriminação depende de comparar a qualidade do sono antes e depois do início e de observar se há cansaço com aceleração, e não apenas fadiga depressiva.

Humor e energia: Uma mudança frequente é o paciente dizer que tem mais disposição antes de sentir melhora proporcional do humor. Isso pode favorecer retomada de tarefas e presença na sessão, mas também pode criar um descompasso clínico: mais energia para agir sem redução equivalente de desesperança, culpa ou autocrítica. Esse ponto merece atenção porque pode ser confundido tanto com melhora robusta quanto com agravamento do quadro, e a diferença aparece na qualidade da experiência subjetiva, não apenas no nível de atividade.

Apetite e peso: Alguns pacientes relatam menos fome, menor interesse por comida ou perda de peso percebida, o que pode surgir como dado lateral e não como queixa principal. Em certos contextos isso é vivido com alívio; em outros, aumenta fragilidade física, irritabilidade ou preocupação corporal. A leitura pode se embaralhar com sintomas depressivos, rotina caótica, tabagismo em mudança ou outras medicações, então vale situar se a alteração de apetite acompanha a introdução do remédio e se repercute na funcionalidade cotidiana.

Sexualidade: A bupropiona às vezes entra na história clínica justamente quando houve dificuldade sexual com outros antidepressivos, e isso muda o foco da escuta. O terapeuta pode notar recuperação de desejo ou menor interferência sexual, mas também encontrar persistência da queixa, o que pede diferenciar efeito medicamentoso de conflito relacional, humor deprimido residual ou ansiedade de desempenho. Como o tema costuma ser subnotificado, a ausência de menção espontânea não significa ausência de impacto clínico.

Adesão e interrupções: Esquecimentos, pausas por conta própria e retomadas irregulares podem produzir uma narrativa de oscilação que parece instabilidade do quadro. Na sessão, isso

aparece quando o paciente descreve dias de maior aceleração, pior sono ou queda de ânimo sem conseguir inicialmente ligar essas mudanças ao padrão de uso. Mais do que confirmar causalidade, interessa mapear a cronologia, porque a adesão irregular frequentemente confunde a avaliação da resposta terapêutica e da tolerabilidade."

O que observar em sessão

- **Ativação inicial:** No início, alguns pacientes chegam mais ligados, falantes, com sensação de energia aumentada ou urgência para agir. Em parte dos casos isso acompanha uma retomada funcional; em outros, vem junto de inquietação, irritabilidade ou sensação corporal de aceleração que não combina com melhora subjetiva do humor. A leitura pode se confundir com alívio por eventos de vida, com traços habituais de ansiedade ou com uso irregular, especialmente quando o paciente descreve dias muito diferentes entre si sem mudança externa correspondente.

Ansiedade e irritabilidade: A sessão pode mostrar menor lentificação, mas maior reatividade, impaciência e tolerância reduzida à frustração. Isso pode ser lido apressadamente como piora global do quadro, quando às vezes se trata de uma ativação desconfortável no começo do uso; em outros casos, a irritabilidade já fazia parte da depressão ou de conflitos atuais e apenas ficou mais visível com menos apatia. Vale observar se a tensão aparece como algo novo na linha de base, se tem horário mais marcado e se o paciente a associa ao período após iniciar ou retomar a medicação.

Sono: Insônia inicial, sono mais leve ou dificuldade para desacelerar à noite podem aparecer cedo e impactar a sessão por cansaço, menor tolerância afetiva e pior capacidade de elaboração. O risco clínico é atribuir tudo à depressão ou à ansiedade de base sem notar que a piora do sono começou junto com a medicação ou após adesão irregular. Quando o paciente já vinha dormindo mal, a discriminação depende de comparar a qualidade do sono antes e depois do início e de observar se há cansaço com aceleração, e não apenas fadiga depressiva.

Humor e energia: Uma mudança frequente é o paciente dizer que tem mais disposição antes de sentir melhora proporcional do humor. Isso pode favorecer retomada de tarefas e presença na sessão, mas também pode criar um descompasso clínico: mais energia para agir sem redução equivalente de desesperança, culpa ou autocrítica. Esse ponto merece atenção porque pode ser confundido tanto com melhora robusta quanto com agravamento do quadro, e a diferença aparece na qualidade da experiência subjetiva, não apenas no nível de atividade.

Apetite e peso: Alguns pacientes relatam menos fome, menor interesse por comida ou perda de peso percebida, o que pode surgir como dado lateral e não como queixa principal. Em certos contextos isso é vivido com alívio; em outros, aumenta fragilidade física, irritabilidade ou preocupação corporal. A leitura pode se embaralhar com sintomas depressivos, rotina caótica, tabagismo em mudança ou outras medicações, então vale situar se a alteração de apetite acompanha a introdução do remédio e se repercute na funcionalidade cotidiana.

Sexualidade: A bupropiona às vezes entra na história clínica justamente quando houve dificuldade sexual com outros antidepressivos, e isso muda o foco da escuta. O terapeuta pode notar recuperação de desejo ou menor interferência sexual, mas também encontrar persistência da queixa, o que pede diferenciar efeito medicamentoso de conflito relacional, humor deprimido residual ou ansiedade de desempenho. Como o tema costuma ser subnotificado, a ausência de menção espontânea não significa ausência de impacto clínico.

Adesão e interrupções: Esquecimentos, pausas por conta própria e retomadas irregulares podem produzir uma narrativa de oscilação que parece instabilidade do quadro. Na sessão, isso

aparece quando o paciente descreve dias de maior aceleração, pior sono ou queda de ânimo sem conseguir inicialmente ligar essas mudanças ao padrão de uso. Mais do que confirmar causalidade, interessa mapear a cronologia, porque a adesão irregular frequentemente confunde a avaliação da resposta terapêutica e da tolerabilidade.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A bupropiona é um antidepressivo atípico que costuma aparecer em quadros depressivos, cessação do tabagismo e, em alguns pacientes, como estratégia quando há queixa sexual com outros antidepressivos. No consultório, o ponto central é acompanhar se a ativação inicial se traduz em mais energia útil ou em piora de ansiedade, irritabilidade e sono. Nas primeiras 1 a 3 semanas podem surgir inquietação, insônia ou sensação de aceleração antes de uma melhora mais consistente do humor, que tende a ficar mais clara ao longo de 4 a 6 semanas. Também vale observar adesão irregular, já que interrupções e retomadas podem confundir a leitura da evolução clínica.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais acelerado, isso vem com sensação de estar melhor e mais capaz de pensar, ou com incômodo, tensão e dificuldade de se organizar? , Essa piora do sono começou junto com o início ou retomada da medicação, ou já vinha no mesmo padrão antes? , Você percebe mais energia acompanhada de alguma redução da tristeza e da desesperança, ou é como se tivesse mais combustível para o mesmo sofrimento? , Essa irritabilidade aparece em situações específicas do seu dia ou surge do nada, como um estado mais corporal e contínuo? , Nos dias em que você esquece, atrasa ou retoma o remédio, você nota alguma mudança previsível no humor, no sono ou na agitação? , Na sua experiência, a dificuldade sexual tem parecido mais ligada ao seu vínculo e ao desejo pelo parceiro, ou ao funcionamento do corpo mesmo quando há interesse?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando a ativação inicial vem com ansiedade importante
- irritabilidade persistente ou insônia que começa a comprometer funcionamento e continuidade do tratamento
- pode valer alinhar com o psiquiatra para reavaliar a tolerabilidade
- Quando o paciente relata mais energia sem melhora proporcional de desesperança
- culpa ou ideação de morte
- pode valer comunicar o médico assistente pelo aumento potencial de risco clínico no início do tratamento
- Quando surgem sinais de expansão incomum do humor
- redução importante da necessidade de sono
- impulsividade ou aceleração muito acima da linha de base
- pode valer contato com o psiquiatra para esclarecer possível virada de humor
- Quando há perda de apetite ou peso com repercussão funcional

Amarelo: alinhar em breve

- fragilidade física ou sofrimento corporal relevante
- pode valer alinhar com o médico para contextualizar o impacto clínico
- Quando a adesão é irregular
- com interrupções e retomadas que embaralham a leitura da evolução
- pode valer comunicar o psiquiatra para que a avaliação médica considere esse padrão
- Quando não há melhora perceptível após cerca de 4 a 6 semanas
- apesar de uso aparentemente regular
- pode valer informar o médico assistente para qualificar a avaliação de resposta

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente passa a ter mais energia e iniciativa enquanto mantém ou intensifica desesperança
- autoacusação ou ideias de morte.: Avaliar risco na própria sessão e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Surge um estado incomum de euforia ou irritabilidade expansiva
- fala muito acelerada
- redução importante do sono e condutas impulsivas fora do padrão habitual.: Tratar como possível mudança aguda de estado de humor e buscar contato médico no mesmo dia
- com apoio adicional se houver risco
- Aparecem confusão importante
- tremores marcados
- agitação intensa ou relato de convulsão
- especialmente se isso é novo no contexto do uso.: Interromper o foco psicoterápico e encaminhar para avaliação médica urgente ou emergência
- além de avisar o médico assistente

Frase clínica

Na bupropiona, o foco é distinguir energia terapêutica de ativação desconfortável, sem perder de vista sono, irritabilidade e risco no início.

123 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA

Substância: Cloridrato de Clomipramina.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Clomipramina, Anafranil, Clo

Uso comum

- A clomipramina é um antidepressivo tricíclico que costuma aparecer no consultório sobretudo em pacientes com TOC, depressão, quadros ansiosos e, às vezes, dor crônica ou sintomas somáticos associados. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta pode notar mais efeitos de tolerabilidade do que mudança clínica consistente; para humor e ansiedade, alguma resposta tende a ficar mais clara ao longo de 3 a 6 semanas, enquanto em sintomas obsessivo-compulsivos a leitura costuma exigir 6 a 12 semanas. O ponto central na sessão é diferenciar sedação, lentificação, boca seca, constipação percebida no relato e impacto sexual de piora do quadro de base, além de observar adesão irregular e interrupções que podem confundir a evolução.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com sonolência, bocejos, menor prontidão associativa ou dificuldade para sustentar elaboração mais complexa. Isso pode ser lido apressadamente como agravamento depressivo, retraimento defensivo ou desinvestimento do processo, quando às vezes coincide temporalmente com o início do medicamento ou com retomadas irregulares. Vale comparar com a linha de base, com o horário em que a sessão ocorre e com o padrão fora do consultório, porque noites mal dormidas, sobrecarga e outras medicações também podem produzir apresentação semelhante.

Ansiedade e ativação inicial: No começo do uso, alguns pacientes descrevem inquietação, aumento da tensão corporal, piora subjetiva da ansiedade ou sensação de estar mais acelerado por dentro sem melhora correspondente do humor. Na sessão, isso pode se confundir com ansiedade habitual, reação a eventos de vida ou intensificação do contato com conteúdos difíceis no processo terapêutico. A discriminação fica mais nítida quando se observa a relação temporal com o início do tratamento, a presença de desconforto físico difuso e se houve mudança abrupta no padrão de reatividade.

Cognição e atenção: Pode surgir queixa de cabeça mais lenta, dificuldade de concentração, lapsos de memória recente ou sensação de pensamento menos fluido, especialmente no início ou quando o paciente oscila na adesão. Em sessão, isso às vezes aparece como perda do fio narrativo, menor capacidade de simbolização ou necessidade de mais perguntas de apoio, o que pode ser confundido com depressão, privação de sono ou uso concomitante de substâncias. O terapeuta ganha precisão ao contrastar esse funcionamento com o baseline e com a variação ao longo da semana.

Sexualidade: Redução de desejo, dificuldade de excitação ou atraso importante para chegar ao orgasmo podem aparecer e nem sempre são trazidos espontaneamente, embora afetem vínculo, autoestima e adesão silenciosa. Sem investigação cuidadosa, isso pode ser atribuído apenas a conflito conjugal, desinteresse afetivo ou persistência do quadro depressivo. Quando a mudança sexual surge depois do início do medicamento e contrasta com o interesse relacional prévio, vale registrar esse descompasso clínico e acompanhar o impacto sobre intimidade e continuidade do tratamento.

Sinais físicos na sessão: Boca seca, constipação referida, visão embaçada ocasional, sudorese e palpitações percebidas pelo paciente podem atravessar a sessão de modo indireto, como necessidade constante de água, desconforto corporal, irritabilidade ou menor disponibilidade para associação livre. Esses elementos podem parecer apenas ansiedade somatizada ou preocupação excessiva com o corpo, mas às vezes entram na equação da tolerabilidade e da adesão. O ponto não é interpretar cada sinal como efeito do remédio, e sim notar quando o conjunto altera o funcionamento e o engajamento terapêutico.

Adesão e descontinuação: A clomipramina pode ser abandonada silenciosamente quando o paciente se sente excessivamente sedado, desconfortável fisicamente ou sexualmente impactado, e isso costuma embaralhar a leitura da evolução clínica. Em sessão, aparecem pistas como melhora e piora em zigue-zague, respostas vagas sobre rotina de uso, retorno abrupto de ansiedade ou mal-estar após alguns dias sem tomar. Diferenciar recaída do quadro,

uso irregular e interrupção por conta própria é central para não atribuir toda oscilação ao processo psíquico ou aos eventos externos."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com sonolência, bocejos, menor prontidão associativa ou dificuldade para sustentar elaboração mais complexa. Isso pode ser lido apressadamente como agravamento depressivo, retraimento defensivo ou desinvestimento do processo, quando às vezes coincide temporalmente com o início do medicamento ou com retomadas irregulares. Vale comparar com a linha de base, com o horário em que a sessão ocorre e com o padrão fora do consultório, porque noites mal dormidas, sobrecarga e outras medicações também podem produzir apresentação semelhante.

Ansiedade e ativação inicial: No começo do uso, alguns pacientes descrevem inquietação, aumento da tensão corporal, piora subjetiva da ansiedade ou sensação de estar mais acelerado por dentro sem melhora correspondente do humor. Na sessão, isso pode se confundir com ansiedade habitual, reação a eventos de vida ou intensificação do contato com conteúdos difíceis no processo terapêutico. A discriminação fica mais nítida quando se observa a relação temporal com o início do tratamento, a presença de desconforto físico difuso e se houve mudança abrupta no padrão de reatividade.

Cognição e atenção: Pode surgir queixa de cabeça mais lenta, dificuldade de concentração, lapsos de memória recente ou sensação de pensamento menos fluido, especialmente no início ou quando o paciente oscila na adesão. Em sessão, isso às vezes aparece como perda do fio narrativo, menor capacidade de simbolização ou necessidade de mais perguntas de apoio, o que pode ser confundido com depressão, privação de sono ou uso concomitante de substâncias. O terapeuta ganha precisão ao contrastar esse funcionamento com o baseline e com a variação ao longo da semana.

Sexualidade: Redução de desejo, dificuldade de excitação ou atraso importante para chegar ao orgasmo podem aparecer e nem sempre são trazidos espontaneamente, embora afetem vínculo, autoestima e adesão silenciosa. Sem investigação cuidadosa, isso pode ser atribuído apenas a conflito conjugal, desinteresse afetivo ou persistência do quadro depressivo. Quando a mudança sexual surge depois do início do medicamento e contrasta com o interesse relacional prévio, vale registrar esse descompasso clínico e acompanhar o impacto sobre intimidade e continuidade do tratamento.

Sinais físicos na sessão: Boca seca, constipação referida, visão embaçada ocasional, sudorese e palpitações percebidas pelo paciente podem atravessar a sessão de modo indireto, como necessidade constante de água, desconforto corporal, irritabilidade ou menor disponibilidade para associação livre. Esses elementos podem parecer apenas ansiedade somatizada ou preocupação excessiva com o corpo, mas às vezes entram na equação da tolerabilidade e da adesão. O ponto não é interpretar cada sinal como efeito do remédio, e sim notar quando o conjunto altera o funcionamento e o engajamento terapêutico.

Adesão e descontinuação: A clomipramina pode ser abandonada silenciosamente quando o paciente se sente excessivamente sedado, desconfortável fisicamente ou sexualmente impactado, e isso costuma embaralhar a leitura da evolução clínica. Em sessão, aparecem pistas como melhora e piora em zigue-zague, respostas vagas sobre rotina de uso, retorno abrupto de ansiedade ou mal-estar após alguns dias sem tomar. Diferenciar recaída do quadro,

uso irregular e interrupção por conta própria é central para não atribuir toda oscilação ao processo psíquico ou aos eventos externos.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A clomipramina é um antidepressivo tricíclico que costuma aparecer no consultório sobretudo em pacientes com TOC, depressão, quadros ansiosos e, às vezes, dor crônica ou sintomas somáticos associados. Nas primeiras 1 a 3 semanas, o terapeuta pode notar mais efeitos de tolerabilidade do que mudança clínica consistente; para humor e ansiedade, alguma resposta tende a ficar mais clara ao longo de 3 a 6 semanas, enquanto em sintomas obsessivo-compulsivos a leitura costuma exigir 6 a 12 semanas. O ponto central na sessão é diferenciar sedação, lentificação, boca seca, constipação percebida no relato e impacto sexual de piora do quadro de base, além de observar adesão irregular e interrupções que podem confundir a evolução.

Perguntas úteis

- "Quando essa lentidão ou sonolência aparece, ela fica parecida com o seu pior momento depressivo ou é mais um corpo pesado com a cabeça menos ágil, mesmo sem tristeza proporcional? , Essa piora da ansiedade começou junto com alguma situação da sua vida ou apareceu como uma inquietação mais corporal e sem um gatilho emocional tão claro? , Você percebe essa dificuldade de concentração o dia todo ou ela varia bastante, com momentos em que parece mais ligada ao horário, ao cansaço ou ao uso irregular? , Na sua vida sexual, a mudança parece mais ligada ao vínculo e ao desejo pelo parceiro ou a uma dificuldade corporal que surgiu apesar de o interesse afetivo continuar presente? , Quando você teve essa oscilação recente, houve dias em que deixou de tomar, tomou de modo diferente do habitual ou evitou por causa de algum incômodo? , Esse desconforto físico que você descreve vem junto de medo e antecipação, como na sua ansiedade de costume, ou aparece mesmo quando você se sente emocionalmente mais estável?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- cogita interromper por conta própria ou admite uso muito irregular por causa de sedação
- desconforto físico ou impacto sexual
- pode valer alinhar com o psiquiatra para evitar que a evolução seja lida de forma equivocada
- Quando a lentificação
- a sonolência ou a piora cognitiva começam a comprometer trabalho
- direção
- cuidado com filhos ou a própria participação na terapia
- pode valer comunicar o médico assistente para reavaliar a tolerabilidade clínica
- Quando surgem palpitações persistentes
- mal-estar físico relevante ou combinação de vários incômodos corporais que o paciente associa ao início do tratamento

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer contato com o psiquiatra para checar segurança e continuidade do acompanhamento
- Quando não há melhora minimamente perceptível após uma janela compatível de acompanhamento
- especialmente em TOC depois de várias semanas
- pode valer alinhar com o médico assistente para qualificar a leitura entre não resposta
- adesão irregular e fatores contextuais
- Quando aparece piora importante da ansiedade
- agitação incomum ou mudança abrupta de padrão de sono e energia nas primeiras semanas
- pode valer comunicar o psiquiatra para discriminar tolerabilidade inicial de outra inflexão clínica

Vermelho: tratar como urgência

- Surge ideação suicida nova ou nitidamente intensificada
- sobretudo nas primeiras semanas
- com piora de agitação
- desesperança ou impulsividade.: Fazer avaliação de risco na sessão e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente chega muito acelerado
- dormindo pouco sem cansaço
- mais expansivo ou irritável do que seu padrão
- com fala pressionada e aumento incomum de impulsos ou projetos.: Tratar como mudança aguda de estado
- registrar sinais observáveis e buscar contato médico no mesmo dia
- Há relato de desmaio
- quase desmaio
- palpitações intensas acompanhadas de mal-estar importante
- ou rebaixamento acentuado do nível de alerta na sessão.: Interromper o enquadre habitual
- avaliar necessidade de atendimento de urgência e acionar suporte imediato

Frase clínica

Na terapia, o foco com clomipramina é separar lentificação, tolerabilidade e adesão irregular da evolução real do quadro.

124 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA

Substância: Cloridrato de Imipramina.

Nomes Comerciais: Imipra

Uso comum

- Cloridrato de imipramina é um antidepressivo tricíclico que pode aparecer em pacientes tratados por depressão, quadros ansiosos, pânico, dor crônica e, em alguns contextos, enurese. No consultório, costuma exigir atenção maior nas primeiras 2 a 4 semanas, quando efeitos de tolerabilidade e oscilação entre sedação e ativação podem ficar mais evidentes antes de uma melhora mais consistente do humor, que tende a ser acompanhada ao longo de 4 a 8 semanas. Interrupções abruptas também podem produzir mal-estar perceptível em poucos dias. O ponto central na sessão é diferenciar piora do quadro de base, efeito do medicamento e adesão irregular quando surgem sonolência, lentificação, inquietação, boca seca, constipação, visão turva, palpitações ou queda subjetiva de rendimento.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com sonolência, bocejos, maior latência para responder e sensação de “cabeça pesada”, sobretudo no início do tratamento ou após mudanças recentes na rotina de uso. Isso pode se confundir com agravamento depressivo, privação de sono, uso concomitante de álcool ou outros sedativos, e também com exaustão por eventos de vida. Vale observar se a lentificação aparece como novidade em relação à baseline e se varia ao longo do dia, porque essa oscilação ajuda a separar efeito medicamentoso de rebaixamento global do humor.

Ativação e ansiedade: Apesar do perfil mais sedativo em muitos casos, alguns pacientes chegam mais inquietos, com sensação corporal de aceleração, piora transitória da ansiedade ou aumento de sensibilidade a estímulos nas primeiras semanas. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, tensão por estressores recentes ou até início de melhora com mais energia para falar do sofrimento. A discriminação clínica ganha precisão quando se investiga se a inquietação surgiu junto do início do medicamento, se é mais física do que cognitiva e se veio sem mudança proporcional no conteúdo das preocupações.

Humor e virada: Quando há resposta terapêutica, o paciente pode recuperar iniciativa e reatividade afetiva antes de relatar alívio pleno do humor deprimido, o que altera o padrão da sessão. Em pessoas com vulnerabilidade bipolar, uma elevação abrupta do humor, redução importante da necessidade de sono, fala pressionada, expansividade ou irritabilidade fora da linha de base merece leitura cautelosa, porque pode ser confundida com melhora legítima. Também é útil considerar eventos positivos recentes e traços temperamentais prévios antes de atribuir a mudança ao medicamento.

Cognição e anticolinérgicos: Boca seca, constipação, visão embaçada, sensação de confusão leve e dificuldade de concentração podem aparecer e interferir no trabalho terapêutico, inclusive reduzindo a capacidade de elaboração em sessão. Esses sinais às vezes são lidos como desinteresse, resistência, piora depressiva ou sobrecarga emocional, quando podem estar ligados ao tratamento ou a outras medicações com efeito semelhante. O terapeuta ganha mais clareza ao notar se a queda de nitidez mental veio acompanhada de sinais físicos no mesmo período e se o paciente passou a evitar atividades por desconforto corporal.

Adesão e descontinuação: A imipramina pode ser abandonada silenciosamente quando o paciente se incomoda com sedação, boca seca, constipação, palpitações ou sensação de estranhamento corporal, especialmente se ele não nomeia isso espontaneamente. Na sessão, a irregularidade de uso pode aparecer como oscilação abrupta entre encontros, retorno de sintomas em poucos dias, mal-estar difuso ou narrativa vaga sobre “não estar conseguindo manter”. Isso pode ser confundido com recaída, ambivalência em relação ao tratamento ou desorganização geral, por isso vale explorar mudanças recentes no padrão de uso sem assumir má adesão como dado.

Risco e segurança: Por ser um medicamento que pode trazer repercussões clínicas relevantes quando usado de forma irregular, em excesso ou em contexto de ideação suicida, a avaliação de segurança precisa permanecer concreta e observacional. Na sessão, ganham peso sinais como piora súbita com confusão, palpitações marcadas, desmaio, fala muito acelerada com redução

importante do sono, ou menção a guardar comprimidos com finalidade autolesiva. Esses elementos não substituem avaliação médica, mas mudam o limiar para comunicação rápida com o assistente e, em alguns casos, para ação no mesmo dia."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com sonolência, bocejos, maior latência para responder e sensação de “cabeça pesada”, sobretudo no início do tratamento ou após mudanças recentes na rotina de uso. Isso pode se confundir com agravamento depressivo, privação de sono, uso concomitante de álcool ou outros sedativos, e também com exaustão por eventos de vida. Vale observar se a lentificação aparece como novidade em relação à baseline e se varia ao longo do dia, porque essa oscilação ajuda a separar efeito medicamentoso de rebaixamento global do humor.

Ativação e ansiedade: Apesar do perfil mais sedativo em muitos casos, alguns pacientes chegam mais inquietos, com sensação corporal de aceleração, piora transitória da ansiedade ou aumento de sensibilidade a estímulos nas primeiras semanas. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, tensão por estressores recentes ou até início de melhora com mais energia para falar do sofrimento. A discriminação clínica ganha precisão quando se investiga se a inquietação surgiu junto do início do medicamento, se é mais física do que cognitiva e se veio sem mudança proporcional no conteúdo das preocupações.

Humor e virada: Quando há resposta terapêutica, o paciente pode recuperar iniciativa e reatividade afetiva antes de relatar alívio pleno do humor deprimido, o que altera o padrão da sessão. Em pessoas com vulnerabilidade bipolar, uma elevação abrupta do humor, redução importante da necessidade de sono, fala pressionada, expansividade ou irritabilidade fora da linha de base merece leitura cautelosa, porque pode ser confundida com melhora legítima. Também é útil considerar eventos positivos recentes e traços temperamentais prévios antes de atribuir a mudança ao medicamento.

Cognição e anticolinérgicos: Boca seca, constipação, visão embaçada, sensação de confusão leve e dificuldade de concentração podem aparecer e interferir no trabalho terapêutico, inclusive reduzindo a capacidade de elaboração em sessão. Esses sinais às vezes são lidos como desinteresse, resistência, piora depressiva ou sobrecarga emocional, quando podem estar ligados ao tratamento ou a outras medicações com efeito semelhante. O terapeuta ganha mais clareza ao notar se a queda de nitidez mental veio acompanhada de sinais físicos no mesmo período e se o paciente passou a evitar atividades por desconforto corporal.

Adesão e descontinuação: A imipramina pode ser abandonada silenciosamente quando o paciente se incomoda com sedação, boca seca, constipação, palpitações ou sensação de estranhamento corporal, especialmente se ele não nomeia isso espontaneamente. Na sessão, a irregularidade de uso pode aparecer como oscilação abrupta entre encontros, retorno de sintomas em poucos dias, mal-estar difuso ou narrativa vaga sobre “não estar conseguindo manter”. Isso pode ser confundido com recaída, ambivalência em relação ao tratamento ou desorganização geral, por isso vale explorar mudanças recentes no padrão de uso sem assumir má adesão como dado.

Risco e segurança: Por ser um medicamento que pode trazer repercussões clínicas relevantes quando usado de forma irregular, em excesso ou em contexto de ideação suicida, a avaliação de segurança precisa permanecer concreta e observacional. Na sessão, ganham peso sinais como piora súbita com confusão, palpitações marcadas, desmaio, fala muito acelerada com redução

importante do sono, ou menção a guardar comprimidos com finalidade autolesiva. Esses elementos não substituem avaliação médica, mas mudam o limiar para comunicação rápida com o assistente e, em alguns casos, para ação no mesmo dia.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Cloridrato de imipramina é um antidepressivo tricíclico que pode aparecer em pacientes tratados por depressão, quadros ansiosos, pânico, dor crônica e, em alguns contextos, enurese. No consultório, costuma exigir atenção maior nas primeiras 2 a 4 semanas, quando efeitos de tolerabilidade e oscilação entre sedação e ativação podem ficar mais evidentes antes de uma melhora mais consistente do humor, que tende a ser acompanhada ao longo de 4 a 8 semanas. Interrupções abruptas também podem produzir mal-estar perceptível em poucos dias. O ponto central na sessão é diferenciar piora do quadro de base, efeito do medicamento e adesão irregular quando surgem sonolência, lentificação, inquietação, boca seca, constipação, visão turva, palpitações ou queda subjetiva de rendimento.

Perguntas úteis

- "Essa sonolência que apareceu parece mais um cansaço emocional parecido com outros períodos depressivos ou uma sensação corporal nova, como peso, lentidão e dificuldade de ficar desperto? , Quando você se sente mais acelerado, vem junto uma cabeça cheia de preocupações como na sua ansiedade habitual, ou é mais uma agitação no corpo sem um motivo claro? , Essa melhora que você percebeu trouxe também necessidade menor de sono, fala mais rápida, impulsividade ou sensação de estar "bom demais" para o seu padrão? , Nos dias em que você se sente pior, isso aconteceu de forma contínua ao longo das semanas ou apareceu mais de repente depois de algum dia em que você não conseguiu manter o uso como de costume? , A dificuldade de concentração vem acompanhada de boca seca, visão embaçada, intestino preso ou palpitações, ou parece mais ligada ao conteúdo emocional que estamos trabalhando? , Quando o interesse sexual diminuiu, isso veio junto de afastamento afetivo do parceiro e piora da relação, ou o vínculo segue parecido e a mudança parece mais corporal?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- reduzir ou interromper o uso por conta própria por desconforto corporal ou sedação
- pode valer alinhar com o psiquiatra para evitar abandono silencioso e confusão com recaída
- Quando surgem palpitações frequentes
- tontura
- quase desmaio ou mal-estar físico que interfere no funcionamento e no vínculo com o tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente para reavaliar a tolerabilidade
- Quando aparece elevação importante de energia com redução da necessidade de sono
- expansividade
- irritabilidade incomum ou impulsividade fora da linha de base

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer contato com o psiquiatra pela possibilidade de mudança de polaridade do humor
- Quando
- após 4 a 8 semanas de uso aparentemente regular
- não se observa melhora clínica compatível e a sessão segue dominada pelo mesmo padrão depressivo ou ansioso
- pode valer alinhar com o médico para revisão do quadro e da adesão
- Quando o paciente relata interrupções repetidas seguidas de mal-estar em poucos dias
- pode valer comunicar o assistente para diferenciar descontinuação
- tolerabilidade ruim e evolução do transtorno

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a falar em morte com mais urgência
- mostra aumento de energia para agir ou menciona guardar comprimidos para se machucar.: Avalie risco no mesmo atendimento e acione no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente chega muito acelerado
- dormindo muito menos
- falando sem pausa
- mais irritável ou grandioso
- com perda clara do padrão habitual.: Considere mudança aguda do estado de humor e faça contato no mesmo dia com o psiquiatra; acione suporte adicional se houver risco comportamental
- Durante a sessão surgem confusão importante
- desorientação
- palpitações intensas
- desmaio
- dor no peito ou rebaixamento acentuado do nível de alerta.: Interrompa o manejo psicoterápico usual e encaminhe para avaliação médica imediata
- acionando emergência se necessário

Frase clínica

Na terapia, o foco com imipramina é separar sedação, ativação e adesão irregular da evolução real do humor e da ansiedade.

125 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA

Substância: Cloridrato de Nortriptilina.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Nortriptilina, Nortry, Pamelor

Uso comum

- A nortriptilina é um antidepressivo tricíclico que costuma aparecer em pacientes com depressão, quadros ansiosos com componente depressivo e, às vezes, dor crônica ou cefaleia. No consultório, vale acompanhar com atenção as primeiras 1 a 3 semanas, quando podem surgir mais sonolência, boca seca, lentificação ou, em alguns casos, ativação e piora subjetiva da ansiedade antes de benefício mais claro no humor. A resposta terapêutica costuma ser percebida ao longo de 2 a 6 semanas. O ponto central na sessão é diferenciar sedação e embotamento ligados ao uso de melhora depressiva real, além de notar adesão irregular e interrupções silenciosas, que podem confundir a leitura da evolução.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com fala menos espontânea, sonolência, maior latência para responder e sensação de "cabeça pesada". Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento ou resistência, quando às vezes coincide temporalmente com o início do uso ou com retomadas irregulares. Também convém considerar privação de sono, uso de álcool, outras medicações sedativas e o próprio rebaixamento do humor como hipóteses concorrentes.

Humor e acesso afetivo: Quando há início de resposta, o sofrimento pode diminuir antes que o paciente recupere vitalidade, interesse e elaboração mais ampla. Em sessão, isso às vezes aparece como menos choro e menos desesperança, mas também com certo achatamento subjetivo ou menor acesso afetivo, o que pode confundir melhora parcial com embotamento. Eventos de vida, alívio por mudanças externas e flutuações naturais do episódio depressivo também podem explicar parte dessa mudança, então vale comparar com a baseline recente.

Ansiedade e ativação inicial: Nas primeiras semanas, alguns pacientes descrevem inquietação, irritabilidade, sensação de aceleração ou piora da ansiedade, enquanto outros ficam mais lentos e sonolentos. Na sessão, a distinção entre ativação associada ao início do tratamento, ansiedade habitual e agravamento do quadro depende do vínculo temporal, da mudança no padrão corporal e da presença de redução de sono com aumento de energia. Café, estimulantes, estresse agudo e vulnerabilidade bipolar podem embaralhar essa leitura.

Cognição e anticolinérgicos: Boca seca, constipação, visão turva e sensação de raciocínio mais travado podem aparecer junto de queixas de atenção e memória, afetando a disponibilidade psíquica na sessão. O terapeuta pode notar mais esforço para organizar a narrativa, cansaço cognitivo e menor tolerância a tarefas reflexivas longas. Isso pode ser confundido com depressão, ansiedade elevada, dor crônica, envelhecimento ou sobrecarga de rotina, especialmente quando o paciente não associa espontaneamente essas mudanças ao período de uso.

Adesão e descontinuação: A tolerabilidade inicial pode levar a tomadas irregulares, esquecimento frequente ou interrupção sem aviso, sobretudo quando o paciente sente mais desconforto antes de notar benefício. Em sessão, isso costuma aparecer como oscilação difícil de explicar entre encontros, mudança brusca no padrão de sono, retorno de sintomas prévios ou relato vago de que "não estava fazendo bem". Sem explorar a regularidade do uso, o terapeuta pode atribuir essas variações apenas ao curso do quadro ou a eventos interpessoais recentes.

Risco de virada: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar, uma aparente melhora rápida demais pode vir acompanhada de expansividade, irritabilidade, redução importante da necessidade de sono, fala acelerada e aumento de impulsividade. Na psicoterapia, isso pode ser confundido com saída da depressão, retomada de autoestima ou alívio após um período muito sofrido. O que ajuda a discriminar é a mudança de qualidade do funcionamento, especialmente quando há aceleração, grandiosidade ou quebra do padrão habitual do paciente."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter um ritmo mais lento, com fala menos espontânea, sonolência, maior latência para responder e sensação de “cabeça pesada”. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinvestimento ou resistência, quando às vezes coincide temporalmente com o início do uso ou com retomadas irregulares. Também convém considerar privação de sono, uso de álcool, outras medicações sedativas e o próprio rebaixamento do humor como hipóteses concorrentes.

Humor e acesso afetivo: Quando há início de resposta, o sofrimento pode diminuir antes que o paciente recupere vitalidade, interesse e elaboração mais ampla. Em sessão, isso às vezes aparece como menos choro e menos desesperança, mas também com certo achatamento subjetivo ou menor acesso afetivo, o que pode confundir melhora parcial com embotamento. Eventos de vida, alívio por mudanças externas e flutuações naturais do episódio depressivo também podem explicar parte dessa mudança, então vale comparar com a baseline recente.

Ansiedade e ativação inicial: Nas primeiras semanas, alguns pacientes descrevem inquietação, irritabilidade, sensação de aceleração ou piora da ansiedade, enquanto outros ficam mais lentos e sonolentos. Na sessão, a distinção entre ativação associada ao início do tratamento, ansiedade habitual e agravamento do quadro depende do vínculo temporal, da mudança no padrão corporal e da presença de redução de sono com aumento de energia. Café, estimulantes, estresse agudo e vulnerabilidade bipolar podem embaralhar essa leitura.

Cognição e anticolinérgicos: Boca seca, constipação, visão turva e sensação de raciocínio mais travado podem aparecer junto de queixas de atenção e memória, afetando a disponibilidade psíquica na sessão. O terapeuta pode notar mais esforço para organizar a narrativa, cansaço cognitivo e menor tolerância a tarefas reflexivas longas. Isso pode ser confundido com depressão, ansiedade elevada, dor crônica, envelhecimento ou sobrecarga de rotina, especialmente quando o paciente não associa espontaneamente essas mudanças ao período de uso.

Adesão e descontinuação: A tolerabilidade inicial pode levar a tomadas irregulares, esquecimento frequente ou interrupção sem aviso, sobretudo quando o paciente sente mais desconforto antes de notar benefício. Em sessão, isso costuma aparecer como oscilação difícil de explicar entre encontros, mudança brusca no padrão de sono, retorno de sintomas prévios ou relato vago de que “não estava fazendo bem”. Sem explorar a regularidade do uso, o terapeuta pode atribuir essas variações apenas ao curso do quadro ou a eventos interpessoais recentes.

Risco de virada: Em pacientes com vulnerabilidade bipolar, uma aparente melhora rápida demais pode vir acompanhada de expansividade, irritabilidade, redução importante da necessidade de sono, fala acelerada e aumento de impulsividade. Na psicoterapia, isso pode ser confundido com saída da depressão, retomada de autoestima ou alívio após um período muito sofrido. O que ajuda a discriminar é a mudança de qualidade do funcionamento, especialmente quando há aceleração, grandiosidade ou quebra do padrão habitual do paciente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A nortriptilina é um antidepressivo tricíclico que costuma aparecer em pacientes com depressão, quadros ansiosos com componente depressivo e, às vezes, dor crônica ou cefaleia. No consultório, vale acompanhar com atenção as primeiras 1 a 3 semanas, quando podem surgir mais sonolência, boca seca, lentificação ou, em alguns casos, ativação e piora subjetiva da ansiedade antes de benefício mais claro no humor. A resposta terapêutica costuma ser percebida ao longo de 2 a 6 semanas. O ponto central na sessão é diferenciar sedação e embotamento ligados ao uso de melhora depressiva real, além de notar adesão irregular e interrupções silenciosas, que podem confundir a leitura da evolução.

Perguntas úteis

- "Essa lentidão ou sonolência apareceu junto com o início do remédio, ou já vinha no mesmo padrão antes? , Você sente que está menos triste porque está melhor, ou mais “amortecido”, com menos acesso ao que sente em geral? , Quando a ansiedade aumentou, veio como preocupação parecida com a de sempre ou como uma inquietação corporal diferente do seu padrão habitual? , Nos dias em que você esquece, atrasa ou evita tomar, percebe alguma mudança no sono, no corpo ou no humor no dia seguinte? , Essa melhora de energia veio com mais clareza e organização, ou com menos sono, mais pressa, impulsividade ou sensação de estar acelerado demais? , A dificuldade de concentração parece acompanhar tristeza e desânimo, ou surgiu junto com sensação de boca seca, visão estranha, cansaço e raciocínio travado?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- reduzir espontaneamente a adesão ou cogitar abandono por desconforto inicial
- pode valer alinhar com o psiquiatra para prevenir interrupção silenciosa e leitura equivocada de “falha” do tratamento
- Quando surge piora importante de inquietação
- irritabilidade ou ansiedade nas primeiras semanas
- especialmente se vier com redução de sono e aceleração
- pode valer contato com o médico para esclarecer se há ativação clinicamente relevante
- Quando a sessão mostra sedação persistente
- lentificação marcante ou prejuízo funcional novo após o início do uso
- pode valer comunicar o psiquiatra para avaliação da tolerabilidade
- Quando aparecem sinais de possível virada de humor
- como fala muito acelerada
- expansividade fora do padrão e queda importante da necessidade de sono
- pode valer alinhamento rápido com o médico assistente
- Quando
- após cerca de 4 a 6 semanas de uso aparentemente regular

Amarelo: alinhar em breve

- não se observa qualquer mudança clínica perceptível
- pode valer comunicar o psiquiatra para atualização do quadro
- Quando o paciente relata interrupção por conta própria seguida de mal-estar
- piora abrupta do humor ou retorno intenso de sintomas
- pode valer informar o médico para contextualizar a evolução recente

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a relatar ideação suicida nova ou mais intensa
- com maior agitação
- impulsividade ou sensação de não conseguir se segurar.: Avalie risco imediatamente
- acione rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- e encaminhe para emergência quando houver risco iminente
- A sessão mostra mudança abrupta para fala pressionada
- redução importante da necessidade de sono
- expansividade ou irritabilidade incomum e aumento de impulsividade.: Trate como possível virada de humor
- registre os sinais observáveis e busque contato médico no mesmo dia; acione suporte adicional se houver risco comportamental
- Além de mal-estar intenso
- o paciente aparece confuso
- muito agitado
- suando
- com tremor evidente ou rigidez corporal fora do padrão habitual.: Considere urgência clínica
- interrompa o foco psicoterápico e encaminhe para avaliação médica imediata ou emergência

Frase clínica

O foco é distinguir melhora depressiva real de sedação, embotamento e adesão irregular, sem perder sinais de ativação ou virada de humor.

126 CLORIDRATO DE TRAZODONA

Substância: Cloridrato de Trazodona.

Nomes Comerciais: Sonic, Cloridrato de Trazodona, Motraz, Donaren, Donaren Retard, Inseris Xr, Donaren® Lp, Lumbra, Azod, Loredon, Raz Xr, Tradep

Uso comum

- A trazodona é um antidepressivo frequentemente encontrado no consultório tanto em quadros depressivos quanto quando foi introduzida com foco em sono fragmentado ou insônia associada a ansiedade e humor deprimido. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta costuma acompanhar mais de perto sedação, lentificação, tontura ao levantar e mudanças no padrão de sono; o efeito sobre humor tende a ser mais legível ao longo de 2 a 6 semanas. Quando há uso irregular ou interrupção por conta própria, a leitura clínica pode se confundir com retorno da insônia, piora ansiosa ou oscilação do humor. O ponto central na sessão é diferenciar repouso restaurador de sedação residual e melhora depressiva de embotamento ou baixa energia.

O paciente pode relatar

- **"Sono e vigília:** Muitos pacientes chegam descrevendo que dormem mais rápido ou acordam menos durante a noite, mas parte deles passa a relatar despertar pesado, dificuldade para engrenar pela manhã ou sensação de sono não reparador. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais lenta, bocejos, menor espontaneidade e redução do acesso associativo, o que pode ser confundido com piora depressiva ou exaustão por rotina. Vale situar se a mudança surgiu logo após o início do uso, se varia conforme a regularidade das tomadas e se o paciente está de fato mais descansado ou apenas mais sedado.

Sedação e lentificação: Além do sono noturno, pode surgir uma lentificação global que o paciente nomeia como calma, moleza ou cabeça pesada. O terapeuta pode observar tempo de resposta aumentado, menor reatividade emocional e queda de iniciativa dentro da própria sessão, o que às vezes parece melhora da ansiedade quando, na verdade, há redução inespecífica de ativação. Eventos de vida, privação de sono prévia, uso concomitante de álcool ou outros sedativos e adesão irregular podem embaralhar essa leitura.

Humor e acesso afetivo: Quando a trazodona está ajudando, o paciente tende a chegar menos exaurido, com mais tolerância à frustração e algum retorno de interesse, muitas vezes mediado por noites melhores. Em outros casos, a redução da intensidade afetiva pode ser vivida como alívio, mas também como certo achatamento subjetivo, com menos sofrimento e menos vitalidade ao mesmo tempo. Na clínica, importa distinguir melhora do humor de um amortecimento inespecífico, especialmente quando a narrativa fica mais pobre sem ganho claro de funcionalidade.

Tontura e sinais físicos: Tontura ao levantar, sensação de fraqueza ou instabilidade podem aparecer no relato e, às vezes, ficam visíveis quando o paciente se move mais devagar, muda de posição com cautela ou menciona receio de cair. Esses sinais podem ser atribuídos pelo próprio paciente a ansiedade, labirintite, jejum ou cansaço, e nem sempre são espontaneamente conectados ao início do medicamento. Se surgem nas primeiras semanas ou após retomadas irregulares, vale registrar o contexto e o impacto funcional, porque podem influenciar adesão silenciosa.

Adesão e interrupção: Como parte dos pacientes usa a trazodona com expectativa muito centrada no sono, a adesão pode oscilar quando o efeito subjetivo não corresponde ao esperado ou quando a sedação matinal incomoda. Na sessão, isso aparece como uso em dias alternados, omissões em noites específicas ou interrupção sem comunicar, seguida de retorno da insônia e leitura apressada de que o quadro piorou. Diferenciar irregularidade de uso de recaída do transtorno de base costuma ser decisivo para entender mudanças abruptas entre uma sessão e outra.

Ativação incomum: Embora a apresentação mais comum no consultório seja de sedação, em uma minoria podem surgir inquietação, irritabilidade, redução da necessidade de sono ou aceleração subjetiva que destoam da linha de base. O terapeuta pode notar fala mais pressionada, expansividade pouco habitual, aumento de planos e menor freio associativo, o que não deve ser lido automaticamente como simples melhora por ter dormido melhor. Quando esse padrão aparece cedo e com mudança nítida de funcionamento, convém considerar

vulnerabilidade bipolar ou outra desorganização do quadro."

O que observar em sessão

- **Sono e vigília:** Muitos pacientes chegam descrevendo que dormem mais rápido ou acordam menos durante a noite, mas parte deles passa a relatar despertar pesado, dificuldade para engrenar pela manhã ou sensação de sono não reparador. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais lenta, bocejos, menor espontaneidade e redução do acesso associativo, o que pode ser confundido com piora depressiva ou exaustão por rotina. Vale situar se a mudança surgiu logo após o início do uso, se varia conforme a regularidade das tomadas e se o paciente está de fato mais descansado ou apenas mais sedado.

Sedação e lentificação: Além do sono noturno, pode surgir uma lentificação global que o paciente nomeia como calma, moleza ou cabeça pesada. O terapeuta pode observar tempo de resposta aumentado, menor reatividade emocional e queda de iniciativa dentro da própria sessão, o que às vezes parece melhora da ansiedade quando, na verdade, há redução inespecífica de ativação. Eventos de vida, privação de sono prévia, uso concomitante de álcool ou outros sedativos e adesão irregular podem embaralhar essa leitura.

Humor e acesso afetivo: Quando a trazodona está ajudando, o paciente tende a chegar menos exaurido, com mais tolerância à frustração e algum retorno de interesse, muitas vezes mediado por noites melhores. Em outros casos, a redução da intensidade afetiva pode ser vivida como alívio, mas também como certo achatamento subjetivo, com menos sofrimento e menos vitalidade ao mesmo tempo. Na clínica, importa distinguir melhora do humor de um amortecimento inespecífico, especialmente quando a narrativa fica mais pobre sem ganho claro de funcionalidade.

Tontura e sinais físicos: Tontura ao levantar, sensação de fraqueza ou instabilidade podem aparecer no relato e, às vezes, ficam visíveis quando o paciente se move mais devagar, muda de posição com cautela ou menciona receio de cair. Esses sinais podem ser atribuídos pelo próprio paciente a ansiedade, labirintite, jejum ou cansaço, e nem sempre são espontaneamente conectados ao início do medicamento. Se surgem nas primeiras semanas ou após retomadas irregulares, vale registrar o contexto e o impacto funcional, porque podem influenciar adesão silenciosa.

Adesão e interrupção: Como parte dos pacientes usa a trazodona com expectativa muito centrada no sono, a adesão pode oscilar quando o efeito subjetivo não corresponde ao esperado ou quando a sedação matinal incomoda. Na sessão, isso aparece como uso em dias alternados, omissões em noites específicas ou interrupção sem comunicar, seguida de retorno da insônia e leitura apressada de que o quadro piorou. Diferenciar irregularidade de uso de recaída do transtorno de base costuma ser decisivo para entender mudanças abruptas entre uma sessão e outra.

Ativação incomum: Embora a apresentação mais comum no consultório seja de sedação, em uma minoria podem surgir inquietação, irritabilidade, redução da necessidade de sono ou aceleração subjetiva que destoam da linha de base. O terapeuta pode notar fala mais pressionada, expansividade pouco habitual, aumento de planos e menor freio associativo, o que não deve ser lido automaticamente como simples melhora por ter dormido melhor. Quando esse padrão aparece cedo e com mudança nítida de funcionamento, convém considerar

vulnerabilidade bipolar ou outra desorganização do quadro.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A trazodona é um antidepressivo frequentemente encontrado no consultório tanto em quadros depressivos quanto quando foi introduzida com foco em sono fragmentado ou insônia associada a ansiedade e humor deprimido. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta costuma acompanhar mais de perto sedação, lentificação, tontura ao levantar e mudanças no padrão de sono; o efeito sobre humor tende a ser mais legível ao longo de 2 a 6 semanas. Quando há uso irregular ou interrupção por conta própria, a leitura clínica pode se confundir com retorno da insônia, piora ansiosa ou oscilação do humor. O ponto central na sessão é diferenciar repouso restaurador de sedação residual e melhora depressiva de embotamento ou baixa energia.

Perguntas úteis

- "Quando seu sono melhorou, você passou a acordar mais descansado e funcional ou mais pesado e arrastado ao longo da manhã? , Essa sensação de estar mais calmo vem com mais clareza e presença nas coisas, ou com menos energia e menos acesso ao que você sente? , Nos dias em que você dorme pior ou melhor, isso acompanha o uso regular do remédio ou parece responder mais ao que aconteceu na sua rotina e no seu estado emocional? , Quando você se sente mais lento, isso começou depois do remédio ou já fazia parte das fases em que a depressão piorava? , Essa piora recente do sono apareceu junto com noites em que você deixou de tomar, tomou de modo irregular ou mudou algo no seu padrão habitual? , Esse aumento de energia e redução do sono parece um bem-estar estável e organizado, ou veio com aceleração, irritabilidade e atitudes fora do seu padrão?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve sedação matinal persistente
- lentificação importante ou tontura com impacto no trabalho
- direção ou autocuidado
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisão da tolerabilidade clínica
- Quando há uso irregular
- interrupção por conta própria ou retomadas intermitentes seguidas de retorno da insônia ou piora ansiosa
- pode valer comunicar o médico para evitar que a leitura do quadro fique confundida
- Quando a melhora do sono não se acompanha de ganho de energia
- interesse ou funcionalidade após algumas semanas
- pode valer alinhar com o psiquiatra para reavaliar se houve benefício clínico suficiente
- Quando surgem inquietação
- irritabilidade
- fala acelerada
- redução importante da necessidade de sono ou expansividade fora do padrão

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer contato com o psiquiatra pela possibilidade de mudança de polaridade ou ativação paradoxal
- Quando o paciente menciona tontura frequente
- quase quedas ou episódios de desmaio
- pode valer comunicação com o médico assistente pela repercussão funcional e necessidade de avaliação clínica

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem na sessão ideias de morte ou autoagressão que se intensificaram após início recente ou mudança no uso
- especialmente em adolescentes e adultos jovens.: Fazer avaliação de risco no mesmo dia
- acionar psiquiatra e rede de apoio
- e encaminhar para emergência se houver risco iminente
- O paciente chega muito acelerado
- dormindo muito pouco sem cansaço
- com fala pressionada
- irritabilidade ou condutas claramente fora do padrão habitual.: Tratar como mudança aguda relevante
- contatar o psiquiatra no mesmo dia e ampliar suporte e contenção clínica conforme o risco
- Há relato de desmaio
- queda com perda de consciência
- ou tontura intensa acompanhada de mal-estar importante.: Orientar busca de avaliação médica imediata e acionar suporte de emergência se o quadro estiver em curso ou houver risco atual

Frase clínica

Na terapia, o foco com trazodona é separar sono restaurador de sedação residual e melhora do humor de lentificação ou embotamento.

127 CLORIDRATO DE VILAZODONA

Substância: Cloridrato de Vilazodona.

Nomes Comerciais: Aymee

Uso comum

- A vilazodona é um antidepressivo usado sobretudo em quadros depressivos e, por vezes, quando ansiedade e depressão aparecem misturadas no relato. No consultório, costuma importar menos o nome da molécula e mais o padrão temporal: nas primeiras 1 a 3 semanas podem surgir desconfortos que afetam adesão e a sensação de “estar diferente”; entre 4 e 8 semanas já se espera alguma pista de resposta clínica, ainda que parcial. O acompanhamento terapêutico ganha valor ao distinguir ativação inicial de piora ansiosa, melhora real de embotamento afetivo, e efeitos que o paciente pode silenciar por vergonha ou por medo de “atrapalhar” o tratamento, especialmente em sexualidade e trato gastrointestinal.

O paciente pode relatar

- **"Ativação inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais agitados, inquietos ou com sensação de aceleração interna, às vezes descrevendo isso como ansiedade piorando. Em sessão, vale observar fala mais apressada, menor tolerância ao silêncio e dificuldade de permanecer com o afeto sem se mover para a ação. A leitura pode se confundir com estresse recente, expectativa em relação ao tratamento ou com a própria oscilação do quadro ansioso de base; por isso, ajuda situar se houve mudança nítida após o início e se ela se mantém ao longo do dia ou aparece em janelas mais previsíveis.

Humor e acesso afetivo: Quando há resposta, o paciente pode relatar menos peso psíquico, mais disponibilidade para tarefas e algum retorno de interesse, sem que isso signifique elaboração mais profunda ou mudança estrutural do conflito. Em sessão, a diferença entre melhora clínica e embotamento aparece no modo como ele acessa tristeza, ambivalência e nuances emocionais: às vezes sofre menos e pensa melhor; em outras, parece apenas mais plano. Também convém não atribuir tudo ao medicamento, porque eventos de vida favoráveis, alívio situacional e flutuações espontâneas do episódio depressivo podem produzir impressão semelhante.

Ansiedade: A vilazodona pode entrar em cena justamente quando ansiedade e depressão se sobrepõem, o que torna a leitura mais delicada nas primeiras semanas. Alguns pacientes descrevem redução gradual da ruminação e da tensão; outros sentem aumento transitório de nervosismo, irritabilidade ou desconforto corporal, que pode ser confundido com recaída ou com traços habituais de hiperalerta. Na sessão, importa discriminar se a ansiedade está mais cognitiva, mais corporal ou mais ligada a contextos específicos, e se houve mudança no padrão basal desde o início do uso ou em períodos de adesão irregular.

Tolerabilidade e adesão: Desconfortos iniciais, especialmente náusea, mal-estar gastrointestinal ou sensação inespecífica de estranhamento, podem levar o paciente a pular tomadas, testar horários por conta própria ou simplesmente seguir usando de modo irregular sem nomear isso espontaneamente. Em sessão, isso às vezes aparece como resposta "instável", com dias muito diferentes entre si, ou como desânimo com o tratamento antes de tempo suficiente para avaliar efeito. A confusão clínica é frequente: o terapeuta pode ler como resistência, piora do quadro ou baixa motivação, quando parte da oscilação talvez esteja ligada à adesão inconsistente.

Sexualidade: Como em outros antidepressivos, podem surgir mudanças em desejo, excitação ou orgasmo, e esse tema costuma ficar fora da narrativa se não houver espaço clínico para nomeá-lo. O paciente pode interpretar a mudança como problema relacional, perda de amor ou falha pessoal, enquanto o terapeuta pode notar afastamento do tema sexual, constrangimento ou racionalizações súbitas sobre intimidade. Também aqui a leitura pede cuidado: conflitos do casal, depressão em si, vergonha corporal e história sexual prévia podem explicar parte importante do quadro, com ou sem participação do medicamento.

Descontinuação e oscilação: Quando o uso é interrompido abruptamente ou fica irregular, podem aparecer piora rápida do mal-estar, irritabilidade, tontura, sensação de instabilidade ou um retorno abrupto de sintomas que o paciente lê como prova de que "está piorando muito". Na

sessão, chama atenção a mudança temporal: algo que surge em poucos dias, de modo mais brusco do que o padrão habitual do episódio depressivo. Diferenciar descontinuação, recaída e reação a eventos de vida recentes é central, porque a narrativa subjetiva costuma misturar essas camadas e o paciente nem sempre associa a oscilação ao modo como vem tomando a medicação."

O que observar em sessão

- **Ativação inicial:** No começo do uso, alguns pacientes chegam mais agitados, inquietos ou com sensação de aceleração interna, às vezes descrevendo isso como ansiedade piorando. Em sessão, vale observar fala mais apressada, menor tolerância ao silêncio e dificuldade de permanecer com o afeto sem se mover para a ação. A leitura pode se confundir com estresse recente, expectativa em relação ao tratamento ou com a própria oscilação do quadro ansioso de base; por isso, ajuda situar se houve mudança nítida após o início e se ela se mantém ao longo do dia ou aparece em janelas mais previsíveis.

Humor e acesso afetivo: Quando há resposta, o paciente pode relatar menos peso psíquico, mais disponibilidade para tarefas e algum retorno de interesse, sem que isso signifique elaboração mais profunda ou mudança estrutural do conflito. Em sessão, a diferença entre melhora clínica e embotamento aparece no modo como ele acessa tristeza, ambivalência e nuances emocionais: às vezes sofre menos e pensa melhor; em outras, parece apenas mais plano. Também convém não atribuir tudo ao medicamento, porque eventos de vida favoráveis, alívio situacional e flutuações espontâneas do episódio depressivo podem produzir impressão semelhante.

Ansiedade: A vilazodona pode entrar em cena justamente quando ansiedade e depressão se sobrepõem, o que torna a leitura mais delicada nas primeiras semanas. Alguns pacientes descrevem redução gradual da ruminação e da tensão; outros sentem aumento transitório de nervosismo, irritabilidade ou desconforto corporal, que pode ser confundido com recaída ou com traços habituais de hiperalerta. Na sessão, importa discriminar se a ansiedade está mais cognitiva, mais corporal ou mais ligada a contextos específicos, e se houve mudança no padrão basal desde o início do uso ou em períodos de adesão irregular.

Tolerabilidade e adesão: Desconfortos iniciais, especialmente náusea, mal-estar gastrointestinal ou sensação inespecífica de estranhamento, podem levar o paciente a pular tomadas, testar horários por conta própria ou simplesmente seguir usando de modo irregular sem nomear isso espontaneamente. Em sessão, isso às vezes aparece como resposta “instável”, com dias muito diferentes entre si, ou como desânimo com o tratamento antes de tempo suficiente para avaliar efeito. A confusão clínica é frequente: o terapeuta pode ler como resistência, piora do quadro ou baixa motivação, quando parte da oscilação talvez esteja ligada à adesão inconsistente.

Sexualidade: Como em outros antidepressivos, podem surgir mudanças em desejo, excitação ou orgasmo, e esse tema costuma ficar fora da narrativa se não houver espaço clínico para nomeá-lo. O paciente pode interpretar a mudança como problema relacional, perda de amor ou falha pessoal, enquanto o terapeuta pode notar afastamento do tema sexual, constrangimento ou racionalizações súbitas sobre intimidade. Também aqui a leitura pede cuidado: conflitos do casal, depressão em si, vergonha corporal e história sexual prévia podem explicar parte importante do quadro, com ou sem participação do medicamento.

Descontinuação e oscilação: Quando o uso é interrompido abruptamente ou fica irregular, podem aparecer piora rápida do mal-estar, irritabilidade, tontura, sensação de instabilidade ou um retorno abrupto de sintomas que o paciente lê como prova de que “está piorando muito”. Na

sessão, chama atenção a mudança temporal: algo que surge em poucos dias, de modo mais brusco do que o padrão habitual do episódio depressivo. Diferenciar descontinuação, recaída e reação a eventos de vida recentes é central, porque a narrativa subjetiva costuma misturar essas camadas e o paciente nem sempre associa a oscilação ao modo como vem tomando a medicação.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A vilazodona é um antidepressivo usado sobretudo em quadros depressivos e, por vezes, quando ansiedade e depressão aparecem misturadas no relato. No consultório, costuma importar menos o nome da molécula e mais o padrão temporal: nas primeiras 1 a 3 semanas podem surgir desconfortos que afetam adesão e a sensação de “estar diferente”; entre 4 e 8 semanas já se espera alguma pista de resposta clínica, ainda que parcial. O acompanhamento terapêutico ganha valor ao distinguir ativação inicial de piora ansiosa, melhora real de embotamento afetivo, e efeitos que o paciente pode silenciar por vergonha ou por medo de “atrapalhar” o tratamento, especialmente em sexualidade e trato gastrointestinal.

Perguntas úteis

- "Essa inquietação que apareceu parece mais ligada a pensamentos e preocupações conhecidas suas, ou é mais uma sensação corporal de não conseguir ficar parado mesmo quando a cabeça não está tão acelerada? , Quando você diz que está “melhor”, você se sente mais disponível para sentir e pensar com clareza, ou mais indiferente, como se as coisas batessem menos mas também tocassem menos? , Essas oscilações dos últimos dias acompanharam algum evento importante da sua semana ou vieram mais de forma brusca, sem um gatilho emocional claro? , Nos dias em que você se sente pior ou muito diferente, houve alguma mudança no jeito como você tomou a medicação, mesmo que tenha parecido pequena? , Na sexualidade, a mudança parece mais um afastamento do parceiro ou da relação, ou seu corpo e sua resposta sexual é que ficaram diferentes mesmo quando o interesse afetivo está presente? , A piora da ansiedade aconteceu logo após começar a medicação e ficou mais constante ao longo do dia, ou segue o mesmo padrão antigo de aparecer em situações específicas?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente relata uso irregular
- pulos frequentes ou interrupção por conta própria
- pode valer alinhar com o psiquiatra para contextualizar oscilações clínicas e risco de abandono silencioso do tratamento
- Quando a ansiedade
- inquietação ou irritabilidade aumentam de forma nítida nas primeiras semanas e começam a comprometer funcionamento
- vínculo ou permanência no tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente para reavaliação clínica
- Quando surgem dificuldades sexuais persistentes que afetam vínculo
- autoestima ou adesão

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o psiquiatra porque esse é um motivo comum de manutenção silenciosa do sofrimento ou de interrupção não informada
- Quando
 - após cerca de 6 a 8 semanas de uso aparentemente regular
 - não há qualquer sinal de melhora subjetiva ou funcional
- pode valer comunicar o médico assistente para situar a ausência de resposta observável
- Quando aparece aceleração importante do humor
- redução marcante da necessidade de sono
- impulsividade ou expansividade fora do padrão do paciente
- pode valer contato com o psiquiatra para esclarecer possível mudança de polaridade
- Quando há piora abrupta após interrupção ou uso errático
- com relato de mal-estar e instabilidade em poucos dias
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar descontinuação de recaída do quadro de base

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- o paciente passa a falar em morte
- desesperança intensa ou autoagressão com aumento de urgência
- planejamento ou perda de freios.: Avalie risco imediatamente
- acione psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhe para emergência quando a contenção ambulatorial não parecer suficiente
- Surge um estado nitidamente fora do padrão
- com pouca necessidade de sono
- aceleração importante
- grandiosidade
- impulsividade ou comportamento desorganizado.: Interrompa o foco habitual da sessão para avaliação de segurança e contato no mesmo dia com o psiquiatra; acione rede de apoio e emergência se houver risco comportamental

Frase clínica

Na terapia, o foco com vilazodona é separar ativação inicial, resposta antidepressiva real e adesão irregular que pode simular piora do quadro.

128 MIRTAZAPINA

Substância: Mirtazapina.

Nomes Comerciais: Remeron, Mirtazapina, Razapina, Catarse Odt, Menelat, Menelat Odt, Zapsy

Uso comum

- A mirtazapina é um antidepressivo que costuma aparecer no consultório em quadros depressivos, frequentemente quando há insônia, perda de apetite, ansiedade associada ou emagrecimento. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta pode notar mais sono, lentificação subjetiva e aumento do apetite antes de uma mudança mais nítida do humor; a resposta antidepressiva costuma ficar mais legível ao longo de 2 a 6 semanas. O ponto central na sessão é diferenciar sedação útil para um paciente antes exaurido de embotamento, sonolência que atrapalha funcionamento, ou melhora apenas parcial mascarada por mais horas de sono e alimentação.

O paciente pode relatar

- **"Sono e vigília:** Muitos pacientes chegam relatando que passaram a dormir mais rápido ou por mais horas, às vezes com sensação de alívio, às vezes com ressaca matinal e dificuldade para engrenar o dia. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais lenta, bocejos, menor prontidão associativa ou menor acesso afetivo, o que pode ser confundido com piora depressiva, privação de sono prévia finalmente compensada ou rotina desorganizada. Vale observar se a sonolência se concentra no início do tratamento, se melhora com o passar das semanas e se o ganho no sono vem acompanhado de recuperação funcional ou apenas de mais tempo na cama.

Apetite e peso: É comum que o paciente note mais fome, mais interesse por comida ou retomada do prazer alimentar, o que em alguns casos é vivido como recuperação e em outros como perda de controle, culpa ou piora da imagem corporal. Em sessão, mudanças rápidas no padrão alimentar podem alterar humor, autoestima e disposição para sair, trabalhar ou se expor socialmente. A leitura pode se confundir com comer emocional, redução da ansiedade, efeito de outras medicações ou mudanças de rotina; por isso ajuda mapear quando o apetite mudou e como isso se articula com peso, energia e autoimagem.

Humor e reatividade: Quando a medicação começa a ajudar, parte dos pacientes fica menos desesperançada e mais acessível ao vínculo antes de relatar claramente que o humor melhorou. Em outros, o aumento do sono e do apetite produz uma sensação de amparo corporal sem que a depressão tenha cedido na mesma proporção, o que pode dar uma impressão precoce de melhora global. O terapeuta ganha precisão ao comparar a linha de base: há mais interesse, iniciativa e elaboração, ou apenas menos sofrimento agudo com manutenção de apatia, culpa e retraimento?

Ansiedade noturna: Em pacientes com ansiedade mais intensa à noite, ruminação ao deitar ou agitação associada à insônia, pode surgir uma redução do estado de alerta que é percebida como alívio. Isso pode favorecer a sessão por diminuir exaustão e irritabilidade, mas também pode encobrir conflitos que antes apareciam na vigília noturna e agora ficam menos acessíveis ao discurso. Convém diferenciar redução da ansiedade de uma sedação inespecífica, especialmente quando o paciente descreve menos preocupação, mas continua evitando situações, mantendo tensão corporal ou funcionando com grande esforço durante o dia.

Sedação ou embotamento: Alguns pacientes descrevem estar mais calmos, porém menos nítidos por dentro, com menor intensidade emocional, menos espontaneidade ou sensação de operar em marcha reduzida. Na sessão, isso pode ser confundido tanto com melhora de um estado ansioso-depressivo quanto com embotamento afetivo medicamentoso, sobretudo se o sofrimento diminui mas também diminui a capacidade de se implicar, desejar ou discriminar estados internos. A diferença costuma aparecer quando se explora se houve ganho de liberdade psíquica ou apenas amortecimento geral.

Adesão e interrupções: Como a mirtazapina pode alterar rapidamente sono e apetite, alguns pacientes passam a tomar de modo irregular, pulam dias para evitar sonolência ou interrompem sem trazer isso espontaneamente por acharem que o efeito já foi suficiente ou incômodo demais. Na terapia, isso pode aparecer como oscilação abrupta entre sessões: uma semana mais descansado, noutra mais insonizado, irritado ou desorganizado, sem mudança proporcional

nos eventos de vida. Quando o padrão clínico fica serrilhado, vale considerar adesão irregular entre as hipóteses, ao lado de flutuação do quadro de base e uso concomitante de álcool ou outras substâncias."

O que observar em sessão

- **Sono e vigília:** Muitos pacientes chegam relatando que passaram a dormir mais rápido ou por mais horas, às vezes com sensação de alívio, às vezes com ressaca matinal e dificuldade para engrenar o dia. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais lenta, bocejos, menor prontidão associativa ou menor acesso afetivo, o que pode ser confundido com piora depressiva, privação de sono prévia finalmente compensada ou rotina desorganizada. Vale observar se a sonolência se concentra no início do tratamento, se melhora com o passar das semanas e se o ganho no sono vem acompanhado de recuperação funcional ou apenas de mais tempo na cama.

Apetite e peso: É comum que o paciente note mais fome, mais interesse por comida ou retomada do prazer alimentar, o que em alguns casos é vivido como recuperação e em outros como perda de controle, culpa ou piora da imagem corporal. Em sessão, mudanças rápidas no padrão alimentar podem alterar humor, autoestima e disposição para sair, trabalhar ou se expor socialmente. A leitura pode se confundir com comer emocional, redução da ansiedade, efeito de outras medicações ou mudanças de rotina; por isso ajuda mapear quando o apetite mudou e como isso se articula com peso, energia e autoimagem.

Humor e reatividade: Quando a medicação começa a ajudar, parte dos pacientes fica menos desesperançada e mais acessível ao vínculo antes de relatar claramente que o humor melhorou. Em outros, o aumento do sono e do apetite produz uma sensação de amparo corporal sem que a depressão tenha cedido na mesma proporção, o que pode dar uma impressão precoce de melhora global. O terapeuta ganha precisão ao comparar a linha de base: há mais interesse, iniciativa e elaboração, ou apenas menos sofrimento agudo com manutenção de apatia, culpa e retraimento?

Ansiedade noturna: Em pacientes com ansiedade mais intensa à noite, ruminação ao deitar ou agitação associada à insônia, pode surgir uma redução do estado de alerta que é percebida como alívio. Isso pode favorecer a sessão por diminuir exaustão e irritabilidade, mas também pode encobrir conflitos que antes apareciam na vigília noturna e agora ficam menos acessíveis ao discurso. Convém diferenciar redução da ansiedade de uma sedação inespecífica, especialmente quando o paciente descreve menos preocupação, mas continua evitando situações, mantendo tensão corporal ou funcionando com grande esforço durante o dia.

Sedação ou embotamento: Alguns pacientes descrevem estar mais calmos, porém menos nítidos por dentro, com menor intensidade emocional, menos espontaneidade ou sensação de operar em marcha reduzida. Na sessão, isso pode ser confundido tanto com melhora de um estado ansioso-depressivo quanto com embotamento afetivo medicamentoso, sobretudo se o sofrimento diminui mas também diminui a capacidade de se implicar, desejar ou discriminar estados internos. A diferença costuma aparecer quando se explora se houve ganho de liberdade psíquica ou apenas amortecimento geral.

Adesão e interrupções: Como a mirtazapina pode alterar rapidamente sono e apetite, alguns pacientes passam a tomar de modo irregular, pulam dias para evitar sonolência ou interrompem sem trazer isso espontaneamente por acharem que o efeito já foi suficiente ou incômodo demais. Na terapia, isso pode aparecer como oscilação abrupta entre sessões: uma semana mais descansado, noutra mais insonizado, irritado ou desorganizado, sem mudança proporcional

nos eventos de vida. Quando o padrão clínico fica serrilhado, vale considerar adesão irregular entre as hipóteses, ao lado de flutuação do quadro de base e uso concomitante de álcool ou outras substâncias.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A mirtazapina é um antidepressivo que costuma aparecer no consultório em quadros depressivos, frequentemente quando há insônia, perda de apetite, ansiedade associada ou emagrecimento. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o terapeuta pode notar mais sono, lentificação subjetiva e aumento do apetite antes de uma mudança mais nítida do humor; a resposta antidepressiva costuma ficar mais legível ao longo de 2 a 6 semanas. O ponto central na sessão é diferenciar sedação útil para um paciente antes exaurido de embotamento, sonolência que atrapalha funcionamento, ou melhora apenas parcial mascarada por mais horas de sono e alimentação.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está melhor, isso aparece mais como menos sofrimento e mais descanso, ou também como mais interesse, iniciativa e capacidade de se envolver com as coisas? , Esse sono maior tem te deixado mais recuperado ao longo do dia ou mais pesado, lento e com dificuldade de funcionar pela manhã? , A mudança no apetite veio junto com sensação de bem-estar e energia, ou mais como impulso para comer, culpa e incômodo com o corpo? , Nas noites em que você dorme melhor, sua ansiedade realmente diminui no dia seguinte ou ela continua parecida e só fica menos evidente porque você está mais sedado? , Essas oscilações entre uma sessão e outra combinam com algo que aconteceu na sua vida, ou parecem vir em blocos de dias em que seu sono, fome e disposição mudam juntos? , Quando você se sente mais amortecido, isso parece um alívio por não ficar tão tomado pelas emoções ou uma perda de acesso ao que sente e deseja?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando a sonolência matinal
- a lentificação ou o aumento do sono passam a comprometer trabalho
- direção
- cuidado com filhos ou presença mínima na rotina
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar impacto funcional e adesão
- Quando o paciente melhora do sono e do apetite
- mas após 4 a 6 semanas segue com desesperança
- anedonia importante ou retraimento marcante
- pode valer comunicar o médico assistente para contextualizar resposta parcial
- Quando surge aumento importante do apetite
- ganho de peso percebido como muito perturbador ou abandono silencioso por incômodo corporal

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o psiquiatra porque isso frequentemente interfere na continuidade do tratamento
- Quando há uso irregular
- interrupções por conta própria ou oscilação clínica serrilhada sem explicação clara por eventos de vida
- pode valer contato com o médico para compartilhar o padrão observado
- Quando aparece redução do sono com aumento incomum de energia
- aceleração
- impulsividade ou expansividade em paciente com possível vulnerabilidade bipolar
- pode valer comunicação com o psiquiatra para discriminar mudança de humor além da melhora esperada

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- especialmente em adolescentes e adultos jovens
- surge piora importante da ideação suicida
- maior urgência para agir ou sensação de que ficou com menos freio interno.: Fazer avaliação de risco no mesmo atendimento e acionar hoje psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Aparecem redução acentuada da necessidade de sono
- fala muito acelerada
- aumento incomum de energia
- impulsividade ou grandiosidade fora do padrão habitual.: Tratar como mudança aguda de estado
- registrar exemplos concretos e acionar hoje o psiquiatra; envolver rede de apoio se houver risco comportamental
- O paciente chega muito confuso
- excessivamente sonolento a ponto de não sustentar a sessão
- ou relata quedas
- desorientação ou rebaixamento importante do nível de alerta.: Interromper o manejo usual da sessão e buscar avaliação médica no mesmo dia
- com apoio de acompanhante ou serviço de urgência se necessário

Frase clínica

Na mirtazapina, o foco é separar melhora sustentada de humor de sedação útil porém enganosa, sobretudo nas primeiras semanas.

129 TIANEPTINA SÓDICA

Substância: Tianeptina Sódica.

Nomes Comerciais: Stablon

Uso comum

- A tianeptina sódica é um antidepressivo usado em quadros depressivos e, às vezes, em apresentações com ansiedade associada. No consultório, o mais útil costuma ser acompanhar se há mudança gradual de humor, iniciativa e tolerância ao sofrimento ao longo de 2 a 6 semanas, distinguindo isso de oscilação ligada a eventos de vida ou adesão irregular. Nas primeiras semanas, vale atenção a piora subjetiva, inquietação, aumento de impulsividade ou abandono silencioso por desconforto percebido. Quando há interrupções ou uso inconsistente, mudanças bruscas no estado subjetivo podem ser confundidas com recaída do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Humor e reatividade:** Ao longo das semanas, o paciente pode descrever menor peso depressivo, mais capacidade de enfrentar o dia ou, em sentido oposto, sensação de que nada mudou. Na sessão, isso aparece no acesso afetivo, na velocidade de associação e na possibilidade de elaborar sem colapsar em desesperança. A leitura pode se confundir com alívio por melhora circunstancial, defesa por distanciamento afetivo ou adesão irregular, especialmente quando a narrativa de melhora não se sustenta de uma sessão para outra.

Ansiedade e inquietação: Em parte dos pacientes, o início do uso pode coincidir com mais tensão interna, irritabilidade ou sensação de estar ligado demais, o que na sessão pode parecer ansiedade habitual ou reatividade a estressores recentes. Vale observar se a inquietação é nova em relação à baseline, se surgiu perto do início do tratamento e se vem acompanhada de impulsividade ou piora do sono. Também é fácil confundir esse quadro com agravamento do transtorno de ansiedade, uso de outras substâncias ou aceleração ligada a vulnerabilidade bipolar.

Sono e ritmo: Mudanças no sono ajudam a organizar hipóteses: alguns pacientes relatam dormir melhor à medida que o humor melhora, enquanto outros chegam mais cansados, fragmentados ou com ritmo mais irregular. Na sessão, isso pode aparecer como lentificação, menor tolerância à frustração ou dificuldade de sustentar atenção. O ponto de confusão é que insônia e fadiga tanto podem acompanhar o quadro depressivo quanto refletir estresse recente, rotina desorganizada ou uso inconsistente da medicação.

Cognição e presença: Quando há resposta clínica, costuma surgir alguma recuperação de concentração, memória de trabalho e presença subjetiva na sessão, ainda que de forma desigual. Se o paciente parece mais disperso, confuso ou com dificuldade nova de organizar pensamento, isso pede comparação fina com o padrão prévio e com o momento do tratamento. Tais mudanças podem ser lidas apressadamente como resistência, piora depressiva ou traço de personalidade, quando às vezes se articulam mais com sono ruim, ansiedade aumentada ou adesão irregular.

Adesão e interrupções: Como a melhora pode ser parcial e pouco linear no começo, não é raro o paciente testar interrupções, esquecer tomadas ou manter uso irregular sem trazer isso espontaneamente. Na terapia, isso costuma aparecer como narrativa de não sei se está ajudando, oscilação abrupta entre sessões ou atribuição global de mal-estar ao medicamento sem discriminar temporalidade. Diferenciar baixa adesão, expectativa frustrada e piora real do quadro evita leituras excessivamente psicologizantes ou conclusões precipitadas sobre ineficácia.

Impulsividade e segurança: Se nas primeiras semanas surgem mais agitação, irritabilidade, desinibição ou sensação de urgência interna, o terapeuta precisa observar se houve mudança também na capacidade de frear atos e pedir ajuda. Em sessão, isso pode aparecer como fala mais acelerada, menor reflexão antes de agir ou relato de decisões abruptas. O risco de confusão é tomar isso apenas como mais energia ou melhora do humor, quando pode sinalizar piora clínica, sofrimento em escalada ou resposta desfavorável ao tratamento."

O que observar em sessão

- **Humor e reatividade:** Ao longo das semanas, o paciente pode descrever menor peso depressivo, mais capacidade de enfrentar o dia ou, em sentido oposto, sensação de que nada mudou. Na sessão, isso aparece no acesso afetivo, na velocidade de associação e na possibilidade de elaborar sem colapsar em desesperança. A leitura pode se confundir com alívio por melhora circunstancial, defesa por distanciamento afetivo ou adesão irregular, especialmente quando a narrativa de melhora não se sustenta de uma sessão para outra.

Ansiedade e inquietação: Em parte dos pacientes, o início do uso pode coincidir com mais tensão interna, irritabilidade ou sensação de estar "ligado" demais, o que na sessão pode parecer ansiedade habitual ou reatividade a estressores recentes. Vale observar se a inquietação é nova em relação à baseline, se surgiu perto do início do tratamento e se vem acompanhada de impulsividade ou piora do sono. Também é fácil confundir esse quadro com agravamento do transtorno de ansiedade, uso de outras substâncias ou aceleração ligada a vulnerabilidade bipolar.

Sono e ritmo: Mudanças no sono ajudam a organizar hipóteses: alguns pacientes relatam dormir melhor à medida que o humor melhora, enquanto outros chegam mais cansados, fragmentados ou com ritmo mais irregular. Na sessão, isso pode aparecer como lentificação, menor tolerância à frustração ou dificuldade de sustentar atenção. O ponto de confusão é que insônia e fadiga tanto podem acompanhar o quadro depressivo quanto refletir estresse recente, rotina desorganizada ou uso inconsistente da medicação.

Cognição e presença: Quando há resposta clínica, costuma surgir alguma recuperação de concentração, memória de trabalho e presença subjetiva na sessão, ainda que de forma desigual. Se o paciente parece mais disperso, confuso ou com dificuldade nova de organizar pensamento, isso pede comparação fina com o padrão prévio e com o momento do tratamento. Tais mudanças podem ser lidas apressadamente como resistência, piora depressiva ou traço de personalidade, quando às vezes se articulam mais com sono ruim, ansiedade aumentada ou adesão irregular.

Adesão e interrupções: Como a melhora pode ser parcial e pouco linear no começo, não é raro o paciente testar interrupções, esquecer tomadas ou manter uso irregular sem trazer isso espontaneamente. Na terapia, isso costuma aparecer como narrativa de "não sei se está ajudando", oscilação abrupta entre sessões ou atribuição global de mal-estar ao medicamento sem discriminar temporalidade. Diferenciar baixa adesão, expectativa frustrada e piora real do quadro evita leituras excessivamente psicologizantes ou conclusões precipitadas sobre ineficácia.

Impulsividade e segurança: Se nas primeiras semanas surgem mais agitação, irritabilidade, desinibição ou sensação de urgência interna, o terapeuta precisa observar se houve mudança também na capacidade de frear atos e pedir ajuda. Em sessão, isso pode aparecer como fala mais acelerada, menor reflexão antes de agir ou relato de decisões abruptas. O risco de confusão é tomar isso apenas como "mais energia" ou melhora do humor, quando pode sinalizar piora clínica, sofrimento em escalada ou resposta desfavorável ao tratamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A tianeptina sódica é um antidepressivo usado em quadros depressivos e, às vezes, em apresentações com ansiedade associada. No consultório, o mais útil costuma ser acompanhar se há mudança gradual de humor, iniciativa e tolerância ao sofrimento ao longo de 2 a 6 semanas, distinguindo isso de oscilação ligada a eventos de vida ou adesão irregular. Nas primeiras semanas, vale atenção a piora subjetiva, inquietação, aumento de impulsividade ou abandono silencioso por desconforto percebido. Quando há interrupções ou uso inconsistente, mudanças bruscas no estado subjetivo podem ser confundidas com recaída do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está mais disposto, isso veio com mais clareza e estabilidade ao longo dos dias ou com uma aceleração que às vezes parece difícil de controlar? , Essa piora que você percebeu começou depois de algum evento específico da semana ou apareceu mais como uma mudança interna sem motivo claro? , Nos dias em que você se sente muito diferente, isso costuma acontecer de forma contínua ou coincide com esquecimentos, interrupções ou uso irregular do remédio? , Quando a ansiedade aumenta, ela se parece com a sua ansiedade de costume ou tem algo de novo no corpo e no ritmo, como inquietação, irritabilidade ou urgência para agir? , A dificuldade de concentração está parecida com a da fase depressiva anterior ou surgiu junto com piora do sono, tensão interna ou mudança recente no tratamento? , Quando você diz que não está sentindo quase nada, isso parece alívio do sofrimento ou uma espécie de distanciamento em que até coisas importantes ficam sem impacto?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta piora nítida de inquietação
- impulsividade ou irritabilidade nas primeiras semanas
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar a mudança no contexto do tratamento e do risco clínico
- Quando há oscilação importante entre sessões e o paciente revela uso irregular
- interrupções ou retomadas por conta própria
- pode valer comunicar o médico assistente para que a leitura da resposta clínica não fique distorcida
- Quando
- após cerca de 4 a 6 semanas de uso aparentemente consistente
- não se observa qualquer sinal de melhora em humor
- iniciativa ou sofrimento psíquico
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisão da hipótese clínica
- Quando surgem sinais de aceleração incomum
- redução importante da necessidade de sono
- fala mais pressionada ou expansividade fora do padrão
- pode valer contato com o psiquiatra pela possibilidade de mudança de polaridade do humor

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente considera abandonar silenciosamente o tratamento por desconforto subjetivo ou por concluir sozinho que "não faz efeito"
- pode valer comunicar o médico para evitar descontinuação sem avaliação

Vermelho: tratar como urgência

- Nas primeiras semanas
- o paciente passa a relatar ideação suicida nova ou intensificada
- sobretudo se vier com mais agitação
- impulsividade ou sensação de urgência.: Avalie risco imediatamente
- acione psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhe para emergência quando houver risco iminente
- A sessão mostra mudança abrupta para fala muito acelerada
- redução importante do sono
- expansividade incomum
- desinibição ou projetos grandiosos fora do padrão do paciente.: Considere possível virada de humor
- contate o psiquiatra no mesmo dia e organize proteção clínica conforme o grau de risco

Frase clínica

O foco clínico é separar melhora gradual de humor de inquietação, impulsividade e oscilações produzidas por adesão irregular ou mudança de polaridade.

130 TRANILCIPROMINA

Substância: Tranilcipromina.

Nomes Comerciais: Parnate

Uso comum

- Tranilcipromina é um antidepressivo da classe dos IMAOs, hoje menos frequente no consultório, mas ainda encontrado em depressões mais resistentes ou com padrão atípico. Para o terapeuta, costuma importar sobretudo a fase inicial de 1 a 3 semanas, quando podem aparecer ativação, piora da ansiedade, insônia ou aceleração subjetiva antes de uma melhora mais consistente do humor, que tende a ser acompanhada ao longo de 2 a 6 semanas. Mudanças abruptas no padrão da sessão, adesão irregular e uso concomitante de outras substâncias podem confundir a leitura. O foco clínico é distinguir ativação medicamentosa, melhora real, virada de humor e abandono silencioso por desconforto inicial.

O paciente pode relatar

- **"Ativação inicial:** Nas primeiras semanas, alguns pacientes chegam mais acelerados, inquietos, falando mais rápido ou com dificuldade de permanecer no mesmo eixo associativo. Isso pode se parecer com alívio depressivo legítimo, mas também com ansiedade aumentada, efeito inicial pouco tolerado ou início de uma mudança de polaridade em pessoas vulneráveis. Vale comparar com a linha de base prévia: há mais energia com preservação de crítica e continuidade do self, ou uma aceleração pouco habitual, com expansividade e redução de freios? Adesão irregular, cafeína, outros estimulantes e privação de sono podem embaralhar esse quadro.

Sono e ritmo: Insônia inicial, redução da necessidade percebida de sono ou sono mais fragmentado podem aparecer e alterar bastante o tom da sessão. Em alguns casos, o paciente parece mais desperto e produtivo; em outros, chega irritado, disperso ou com sensação de corpo cansado e mente ligada. A distinção clínica importante é entre um ajuste inicial desconfortável, estresse de vida recente e um padrão de aceleração mais amplo, especialmente quando a diminuição do sono vem sem cansaço proporcional. Oscilações de rotina, trabalho em turnos e uso de álcool ou outras substâncias podem confundir a leitura.

Ansiedade e inquietação: Pode surgir aumento de tensão interna, impaciência ou sensação de estar "ligado demais", às vezes descrita como ansiedade nova ou diferente da habitual. Na sessão, isso pode aparecer como dificuldade de aprofundar, maior reatividade, pressa para concluir raciocínios ou desconforto corporal inespecífico. O ponto é discriminar se se trata do padrão ansioso de base, de ativação relacionada ao início do tratamento ou de inquietação mais marcada que o paciente não reconhece como ansiedade. Quando esse desconforto leva a faltas, redução espontânea do uso ou desejo de abandonar o tratamento sem dizer ao médico, a leitura clínica muda.

Humor e virada: Quando há melhora, ela tende a aparecer como maior acesso afetivo, retomada de interesse e ampliação de iniciativa, sem perda importante de juízo crítico. Se o paciente passa a chegar excessivamente confiante, grandioso, muito mais falante, com planos numerosos e pouca necessidade de sono, convém considerar que não se trata apenas de resposta antidepressiva. Eventos positivos de vida podem produzir entusiasmo legítimo, mas costumam manter proporcionalidade e continuidade com a história do paciente. A sessão ajuda a observar se houve apenas saída da inibição depressiva ou uma mudança qualitativa do funcionamento.

Adesão e descontinuação: Por ser um tratamento que pode gerar desconforto inicial e exigir manejo médico próximo, não é raro que o paciente omita tomadas, altere por conta própria o uso ou simplesmente interrompa sem comunicar. Na terapia, isso costuma aparecer como oscilação difícil de explicar entre sessões, relato vago sobre horários, piora súbita após aparente melhora ou atribuição global de mal-estar ao remédio sem clareza temporal. Também pode haver constrangimento em admitir abandono por medo de desapontar o médico ou o terapeuta. A utilidade clínica está em reconstruir a sequência dos acontecimentos sem confronto e sem presumir causalidade.

Sinais físicos relevantes: Embora o consultório de terapia não seja o lugar para rastreio médico detalhado, alguns sinais corporais associados a mal-estar importante merecem atenção

porque podem aparecer junto de mudança psíquica abrupta. Dor de cabeça intensa e incomum, palpitações marcadas, agitação fora do padrão, confusão, tremor evidente ou sudorese importante durante a sessão não devem ser lidos apenas como ansiedade sem antes situar contexto e temporalidade. Também aqui eventos de vida, pânico, uso de substâncias e outras medicações podem produzir apresentações parecidas. O terapeuta observa, registra o encadeamento e decide sobre necessidade de contato mais rápido com o médico."

O que observar em sessão

- **Ativação inicial:** Nas primeiras semanas, alguns pacientes chegam mais acelerados, inquietos, falando mais rápido ou com dificuldade de permanecer no mesmo eixo associativo. Isso pode se parecer com alívio depressivo legítimo, mas também com ansiedade aumentada, efeito inicial pouco tolerado ou início de uma mudança de polaridade em pessoas vulneráveis. Vale comparar com a linha de base prévia: há mais energia com preservação de crítica e continuidade do self, ou uma aceleração pouco habitual, com expansividade e redução de freios? Adesão irregular, cafeína, outros estimulantes e privação de sono podem embaralhar esse quadro.

Sono e ritmo: Insônia inicial, redução da necessidade percebida de sono ou sono mais fragmentado podem aparecer e alterar bastante o tom da sessão. Em alguns casos, o paciente parece mais desperto e produtivo; em outros, chega irritado, disperso ou com sensação de corpo cansado e mente ligada. A distinção clínica importante é entre um ajuste inicial desconfortável, estresse de vida recente e um padrão de aceleração mais amplo, especialmente quando a diminuição do sono vem sem cansaço proporcional. Oscilações de rotina, trabalho em turnos e uso de álcool ou outras substâncias podem confundir a leitura.

Ansiedade e inquietação: Pode surgir aumento de tensão interna, impaciência ou sensação de estar “ligado demais”, às vezes descrita como ansiedade nova ou diferente da habitual. Na sessão, isso pode aparecer como dificuldade de aprofundar, maior reatividade, pressa para concluir raciocínios ou desconforto corporal inespecífico. O ponto é discriminar se se trata do padrão ansioso de base, de ativação relacionada ao início do tratamento ou de inquietação mais marcada que o paciente não reconhece como ansiedade. Quando esse desconforto leva a faltas, redução espontânea do uso ou desejo de abandonar o tratamento sem dizer ao médico, a leitura clínica muda.

Humor e virada: Quando há melhora, ela tende a aparecer como maior acesso afetivo, retomada de interesse e ampliação de iniciativa, sem perda importante de juízo crítico. Se o paciente passa a chegar excessivamente confiante, grandioso, muito mais falante, com planos numerosos e pouca necessidade de sono, convém considerar que não se trata apenas de resposta antidepressiva. Eventos positivos de vida podem produzir entusiasmo legítimo, mas costumam manter proporcionalidade e continuidade com a história do paciente. A sessão ajuda a observar se houve apenas saída da inibição depressiva ou uma mudança qualitativa do funcionamento.

Adesão e descontinuação: Por ser um tratamento que pode gerar desconforto inicial e exigir manejo médico próximo, não é raro que o paciente omita tomadas, altere por conta própria o uso ou simplesmente interrompa sem comunicar. Na terapia, isso costuma aparecer como oscilação difícil de explicar entre sessões, relato vago sobre horários, piora súbita após aparente melhora ou atribuição global de mal-estar ao remédio sem clareza temporal. Também pode haver constrangimento em admitir abandono por medo de desapontar o médico ou o terapeuta. A utilidade clínica está em reconstruir a sequência dos acontecimentos sem confronto e sem presumir causalidade.

Sinais físicos relevantes: Embora o consultório de terapia não seja o lugar para rastreio médico detalhado, alguns sinais corporais associados a mal-estar importante merecem atenção

porque podem aparecer junto de mudança psíquica abrupta. Dor de cabeça intensa e incomum, palpitações marcadas, agitação fora do padrão, confusão, tremor evidente ou sudorese importante durante a sessão não devem ser lidos apenas como ansiedade sem antes situar contexto e temporalidade. Também aqui eventos de vida, pânico, uso de substâncias e outras medicações podem produzir apresentações parecidas. O terapeuta observa, registra o encadeamento e decide sobre necessidade de contato mais rápido com o médico.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Tranilcipromina é um antidepressivo da classe dos IMAOs, hoje menos frequente no consultório, mas ainda encontrado em depressões mais resistentes ou com padrão atípico. Para o terapeuta, costuma importar sobretudo a fase inicial de 1 a 3 semanas, quando podem aparecer ativação, piora da ansiedade, insônia ou aceleração subjetiva antes de uma melhora mais consistente do humor, que tende a ser acompanhada ao longo de 2 a 6 semanas. Mudanças abruptas no padrão da sessão, adesão irregular e uso concomitante de outras substâncias podem confundir a leitura. O foco clínico é distinguir ativação medicamentosa, melhora real, virada de humor e abandono silencioso por desconforto inicial.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está com mais energia, isso tem vindo com mais clareza e interesse pelas coisas ou com uma sensação de estar acelerado demais para o seu próprio ritmo? , Nessas noites em que você dorme menos, no dia seguinte você se sente cansado e prejudicado ou segue disposto como se não precisasse dormir? , Essa ansiedade que apareceu se parece com a sua ansiedade de costume ou tem um tom mais corporal, mais súbito, como se seu corpo estivesse ligado demais? , Quando seu humor melhorou, você se sentiu mais parecido com você mesmo ou mais expansivo, impulsivo ou confiante do que costuma ser? , Nas semanas em que você oscilou mais, houve alguma mudança no jeito de tomar a medicação, uso de álcool, cafeína, outras substâncias ou alteração importante na rotina? , Quando pensou em parar ou falhar no uso, isso veio porque você se sentia piorando do quadro, por incômodo com algo novo no corpo ou por dificuldade prática de manter a rotina?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta aceleração importante
- fala pressionada
- redução clara do sono sem cansaço e aumento de impulsividade
- pode valer alinhar com o psiquiatra para discutir possível mudança qualitativa do humor
- Quando a ansiedade ou a inquietação nas primeiras semanas ficam intensas a ponto de comprometer vínculo
- presença em sessão ou continuidade do tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente para situar tolerabilidade e risco de abandono silencioso
- Quando há oscilação clínica difícil de entender e o paciente admite uso irregular
- interrupções ou retomadas por conta própria

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer contato com o psiquiatra para alinhar a leitura do quadro
- Quando surgem dor de cabeça muito intensa
- palpitações marcadas
- confusão
- tremor evidente ou sudorese importante em associação temporal com o uso
- pode valer comunicação no mesmo dia para avaliação médica
- Quando
- após algumas semanas
- não se observa qualquer mudança clínica apesar de adesão aparentemente consistente
- pode valer alinhar com o médico para compartilhar a evolução observada em sessão

Vermelho: tratar como urgência

- Ideação suicida que surge ou se intensifica nas primeiras semanas
- especialmente se acompanhada de maior energia
- agitação ou passagem de ruminação para intenção mais organizada.: Avalie risco imediatamente
- acione psiquiatra e rede de apoio no mesmo dia e encaminhe para emergência quando houver risco iminente
- Mudança abrupta para fala muito acelerada
- grandiosidade
- impulsividade
- muitos planos ao mesmo tempo e pouca necessidade de sono
- fora do padrão habitual do paciente.: Trate como urgência clínica
- contate o psiquiatra no mesmo dia e organize contenção com rede de apoio se houver prejuízo de juízo crítico ou risco comportamental
- Durante a sessão
- o paciente apresenta dor de cabeça intensa e incomum
- palpitações marcadas
- sudorese importante
- tremor visível
- confusão ou agitação corporal fora do seu padrão.: Interrompa a exploração psicoterápica
- priorize avaliação médica imediata e acione emergência se houver piora rápida
- desorientação ou mal-estar importante

Frase clínica

Na terapia, o ponto central com tranilcipromina é diferenciar melhora depressiva de ativação excessiva, virada de humor e abandono silencioso.

131 ARMODAFINILA

Substância: Armodafinila.

Nomes Comerciais: Nuvigil

Uso comum

- Armodafinila é um agente promotor de vigília, mais encontrado em pacientes com sonolência diurna importante, transtornos do sono ou, às vezes, em tentativas de sustentar funcionamento sob fadiga persistente. No consultório, o mais útil é acompanhar o que muda nas primeiras 1 a 2 semanas em alerta, ritmo de fala, ansiedade, sono noturno e padrão de funcionamento ao longo do dia. Quando há benefício, ele tende a aparecer cedo; quando surgem desconfortos subjetivos, também costumam ser percebidos no início. O ponto central na sessão é diferenciar ganho de vigília de aceleração ansiosa, sobrecarga autoimposta ou redução artificial do descanso.

O paciente pode relatar

- **"Vigília e ritmo:** Alguns pacientes chegam mais despertos, com maior prontidão cognitiva e menos lentificação, o que pode favorecer presença na sessão e sensação de retomada funcional. Em outros, o aumento de alerta vem junto de fala mais rápida, dificuldade de desacelerar e menor tolerância a pausas, o que pode se confundir com ansiedade basal, pressão externa por desempenho ou privação de sono mantida. Vale observar se a melhora é estável ao longo da semana ou se aparece como um empurrão que mascara exaustão acumulada.

Ansiedade e ativação: Pode surgir inquietação subjetiva, tensão corporal, irritabilidade ou sensação de estar ligado demais, especialmente no começo do uso. Na sessão, isso às vezes se parece com agravamento do quadro ansioso, reatividade a eventos recentes ou uso concomitante de outras substâncias estimulantes, e não convém assumir uma única causa. A discriminação clínica costuma depender de comparar a linha de base anterior com a temporalidade da mudança e com o padrão corporal observado em sessão.

Sono noturno: Mesmo quando o paciente relata mais energia durante o dia, o sono noturno pode ficar mais superficial, tardio ou menos reparador, criando um ciclo em que vigília diurna e cansaço acumulado coexistem. Isso pode ser lido apressadamente como melhora funcional, quando na prática há redução do descanso e aumento de irritabilidade ou fragilidade emocional. Também é fácil confundir com insônia prévia, hábitos de sono desorganizados ou fase de maior estresse externo.

Humor e expansividade: Em parte dos pacientes, o aumento de energia vem sem ganho proporcional de regulação afetiva, e a sessão pode mostrar euforia discreta, autoconfiança incomum, impaciência ou ampliação de projetos. Nem toda melhora de disposição indica virada de humor, mas também nem toda expansividade é apenas alívio por estar menos sonolento. O terapeuta ganha mais precisão quando observa se houve mudança qualitativa do juízo, do freio inibitório e da necessidade de sono, e não só do humor declarado.

Apetite e autocuidado: Alguns pacientes passam a comer em horários mais irregulares ou referem menor percepção de fome, sobretudo quando o dia fica mais acelerado. Na sessão, isso pode aparecer como descuido com pausas básicas, hidratação e organização corporal, algo que também pode decorrer de rotina caótica, metas excessivas ou traços prévios de autoexigência. O ponto clínico não é o sintoma isolado, mas se a ativação está estreitando o espaço de autorregulação.

Adesão e uso instrumental: Por ser percebida como medicação que ajuda a render, o uso pode ganhar um lugar instrumental na relação do paciente com produtividade, estudo ou trabalho. Isso favorece oscilações de adesão, uso mais orientado por demanda do que por rotina e leituras simplificadas do tipo funciona quando preciso, que confundem avaliação clínica na psicoterapia. Quando o padrão de presença, energia e irritabilidade muda muito entre sessões, vale considerar adesão irregular, privação de sono e contexto de desempenho antes de atribuir tudo ao quadro psíquico."

O que observar em sessão

- **Vigília e ritmo:** Alguns pacientes chegam mais despertos, com maior prontidão cognitiva e menos lentificação, o que pode favorecer presença na sessão e sensação de retomada funcional. Em outros, o aumento de alerta vem junto de fala mais rápida, dificuldade de desacelerar e menor tolerância a pausas, o que pode se confundir com ansiedade basal, pressão externa por desempenho ou privação de sono mantida. Vale observar se a melhora é estável ao longo da semana ou se aparece como um empurrão que mascara exaustão acumulada.

Ansiedade e ativação: Pode surgir inquietação subjetiva, tensão corporal, irritabilidade ou sensação de estar "ligado demais", especialmente no começo do uso. Na sessão, isso às vezes se parece com agravamento do quadro ansioso, reatividade a eventos recentes ou uso concomitante de outras substâncias estimulantes, e não convém assumir uma única causa. A discriminação clínica costuma depender de comparar a linha de base anterior com a temporalidade da mudança e com o padrão corporal observado em sessão.

Sono noturno: Mesmo quando o paciente relata mais energia durante o dia, o sono noturno pode ficar mais superficial, tardio ou menos reparador, criando um ciclo em que vigília diurna e cansaço acumulado coexistem. Isso pode ser lido apressadamente como melhora funcional, quando na prática há redução do descanso e aumento de irritabilidade ou fragilidade emocional. Também é fácil confundir com insônia prévia, hábitos de sono desorganizados ou fase de maior estresse externo.

Humor e expansividade: Em parte dos pacientes, o aumento de energia vem sem ganho proporcional de regulação afetiva, e a sessão pode mostrar euforia discreta, autoconfiança incomum, impaciência ou ampliação de projetos. Nem toda melhora de disposição indica virada de humor, mas também nem toda expansividade é apenas alívio por estar menos sonolento. O terapeuta ganha mais precisão quando observa se houve mudança qualitativa do juízo, do freio inibitório e da necessidade de sono, e não só do humor declarado.

Apetite e autocuidado: Alguns pacientes passam a comer em horários mais irregulares ou referem menor percepção de fome, sobretudo quando o dia fica mais acelerado. Na sessão, isso pode aparecer como descuido com pausas básicas, hidratação e organização corporal, algo que também pode decorrer de rotina caótica, metas excessivas ou traços prévios de autoexigência. O ponto clínico não é o sintoma isolado, mas se a ativação está estreitando o espaço de autorregulação.

Adesão e uso instrumental: Por ser percebida como medicação que "ajuda a render", o uso pode ganhar um lugar instrumental na relação do paciente com produtividade, estudo ou trabalho. Isso favorece oscilações de adesão, uso mais orientado por demanda do que por rotina e leituras simplificadas do tipo "funciona quando preciso", que confundem avaliação clínica na psicoterapia. Quando o padrão de presença, energia e irritabilidade muda muito entre sessões, vale considerar adesão irregular, privação de sono e contexto de desempenho antes de atribuir tudo ao quadro psíquico.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Armodafinila é um agente promotor de vigília, mais encontrado em pacientes com sonolência diurna importante, transtornos do sono ou, às vezes, em tentativas de sustentar funcionamento sob fadiga persistente. No consultório, o mais útil é acompanhar o que muda nas primeiras 1 a 2 semanas em alerta, ritmo de fala, ansiedade, sono noturno e padrão de funcionamento ao longo do dia. Quando há benefício, ele tende a aparecer cedo; quando surgem desconfortos subjetivos, também costumam ser percebidos no início. O ponto central na sessão é diferenciar ganho de vigília de aceleração ansiosa, sobrecarga autoimposta ou redução artificial do descanso.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais desperto, isso vem com sensação de clareza e presença ou com um corpo acelerado e difícil de frear? , Nos dias em que você rende mais, você também dorme e se recupera melhor depois, ou parece que está funcionando apesar do cansaço? , Essa mudança de energia aumentou sua capacidade de escolher e se organizar, ou você se percebe mais impulsivo, impaciente ou assumindo coisas demais? , A irritação e a tensão aparecem mesmo em dias emocionalmente tranquilos, ou costumam vir ligadas a conflitos, cobrança e sobrecarga? , Quando sua disposição muda de um dia para o outro, isso acompanha seu sono e sua rotina, ou parece acontecer sem relação clara com o contexto? , Você nota diferença consistente entre dias em que usa a medicação como de costume e dias em que esquece, atrasa ou muda o padrão por conta própria?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar aumento importante de inquietação
- irritabilidade ou insônia logo após o início
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se há relação temporal consistente e risco de abandono silencioso
- Quando surge expansividade incomum
- redução da necessidade de sono
- impulsividade ou aceleração marcante em alguém com possível vulnerabilidade bipolar
- pode valer alinhar com o médico assistente para avaliação mais rápida do quadro
- Quando a melhora de vigília parece vir às custas de privação de sono
- alimentação irregular e sobrecarga crescente
- pode valer comunicar o médico assistente para situar o padrão funcional observado na terapia
- Quando o paciente descreve uso irregular
- por demanda
- ou mudanças por conta própria no modo de tomar
- pode valer alinhar com o médico assistente porque isso dificulta a leitura clínica do que é efeito
- oscilação do quadro ou contexto

Amarelo: alinhar em breve

- Quando não há benefício perceptível após as primeiras 1 a 2 semanas
- mas há custo subjetivo relevante em ansiedade
- sono ou irritabilidade
- pode valer comunicar o médico assistente para informar a experiência clínica observada

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem fala muito pressionada
- redução acentuada da necessidade de sono
- grandiosidade
- impulsividade ou perda importante de freio inibitório
- sobretudo se isso foge claramente da linha de base.: Acionar o médico assistente no mesmo dia e avaliar necessidade de envolver rede de apoio e serviço de urgência conforme o grau de desorganização e risco
- Surge ideação suicida nova ou claramente intensificada
- especialmente junto de agitação
- insônia e piora rápida do estado mental.: Fazer manejo imediato de risco
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

O foco é distinguir vigília útil de aceleração ansiosa, privação de sono e uso instrumental voltado apenas a desempenho.

132 CLORIDRATO DE METILFENIDATO

Substância: Cloridrato de Metilfenidato.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Metilfenidato, Attenze, Medato, Ritalina, Concerta, Consiv, Ragione, Tedeaga, Foq Xr

Uso comum

- O cloridrato de metilfenidato é um estimulante usado sobretudo em TDAH e, em alguns casos, em quadros com desatenção e lentificação importantes. No consultório, o mais útil é acompanhar o padrão temporal: parte dos efeitos percebidos aparece já nos primeiros dias, enquanto o ajuste subjetivo da rotina pode levar algumas semanas; também vale observar diferenças entre manhã, tarde e noite e entre dias de uso regular e irregular. O foco clínico costuma ser menos “se está funcionando” em abstrato e mais como atenção, impulsividade, apetite, sono, irritabilidade e vínculo com tarefas oscilam ao longo do dia e interferem na sessão.

O paciente pode relatar

- **"Oscilação no dia:** Uma mesma pessoa pode chegar mais organizada, objetiva e sustentada em certos horários, e em outros mais dispersa, irritadiça ou "caindo de rendimento". Isso pode se confundir com instabilidade emocional, resistência ao trabalho terapêutico ou simples efeito do cansaço acumulado. Vale comparar o estado em sessão com o horário da tomada, com o período do dia e com o padrão em dias úteis versus fins de semana, porque a oscilação temporal ajuda a diferenciar efeito do medicamento, adesão irregular e variação basal do TDAH.

Apetite e peso: Redução do apetite pode aparecer cedo e, na terapia, às vezes surge menos como queixa direta e mais como pular refeições, irritabilidade no fim do dia, preocupação com o corpo ou menor disponibilidade psíquica quando está sem comer. Isso pode ser lido apressadamente como ansiedade, traço de controle ou conflito alimentar prévio. A discriminação melhora quando o terapeuta observa se a mudança coincide com o início do uso, se varia conforme o horário e se houve repercussão concreta em peso, rotina e humor.

Sono: Dificuldade para desacelerar à noite ou atraso para pegar no sono pode aparecer no começo ou quando a rotina está desorganizada, enquanto sonolência diurna tende a apontar mais para privação de sono, exaustão ou outra medicação associada. Em sessão, isso pode se apresentar como menor tolerância à frustração, pensamento menos flexível ou sensação de "mente acelerada" no fim do dia. Convém diferenciar insônia ligada ao ritmo do medicamento de hiperativação ansiosa habitual, uso tardio, consumo de cafeína e piora global do quadro.

Irritabilidade e reatividade: Alguns pacientes descrevem mais impaciência, respostas curtas ou sensação de estar "no limite", especialmente em transições do dia ou quando estão sem comer e cansados. Na sessão, isso pode ser confundido com aumento de agressividade, piora do humor ou tensão transferencial, quando às vezes o fenômeno é mais situacional e temporal. Observar se a irritabilidade é nova, se aparece em janelas previsíveis e se vem junto de queda de foco ou desconforto corporal ajuda a separar efeito do medicamento, estresse ambiental e desregulação já presente antes.

Ansiedade ou ativação: Em parte dos pacientes, o ganho de energia e prontidão pode ser vivido como melhora; em outros, como inquietação, aperto interno ou aceleração difícil de nomear. O risco clínico na terapia é tomar toda ativação por ansiedade de base, ou o contrário, supor benefício quando o paciente está mais tenso e menos capaz de elaborar. A distinção costuma depender de perguntar se a pessoa está mais funcional e centrada ou apenas mais rápida, mais vigilante e menos tolerante ao próprio desconforto.

Adesão e uso irregular: Com metilfenidato, o padrão de uso frequentemente entra no campo terapêutico: esquecer, evitar em certos dias, usar só para estudar ou trabalhar, interromper em fins de semana, ou omitir o uso por receio de julgamento. Isso pode produzir sessões muito diferentes entre si e confundir a leitura de progresso, motivação e capacidade de insight. Vale mapear regularidade, contexto de uso e razões subjetivas para tomar ou não tomar, porque a irregularidade às vezes explica mais a oscilação clínica do que uma mudança do quadro de base."

O que observar em sessão

- **Oscilação no dia:** Uma mesma pessoa pode chegar mais organizada, objetiva e sustentada em certos horários, e em outros mais dispersa, irritadiça ou “caindo de rendimento”. Isso pode se confundir com instabilidade emocional, resistência ao trabalho terapêutico ou simples efeito do cansaço acumulado. Vale comparar o estado em sessão com o horário da tomada, com o período do dia e com o padrão em dias úteis versus fins de semana, porque a oscilação temporal ajuda a diferenciar efeito do medicamento, adesão irregular e variação basal do TDAH.

Apetite e peso: Redução do apetite pode aparecer cedo e, na terapia, às vezes surge menos como queixa direta e mais como pular refeições, irritabilidade no fim do dia, preocupação com o corpo ou menor disponibilidade psíquica quando está sem comer. Isso pode ser lido apressadamente como ansiedade, traço de controle ou conflito alimentar prévio. A discriminação melhora quando o terapeuta observa se a mudança coincide com o início do uso, se varia conforme o horário e se houve repercussão concreta em peso, rotina e humor.

Sono: Dificuldade para desacelerar à noite ou atraso para pegar no sono pode aparecer no começo ou quando a rotina está desorganizada, enquanto sonolência diurna tende a apontar mais para privação de sono, exaustão ou outra medicação associada. Em sessão, isso pode se apresentar como menor tolerância à frustração, pensamento menos flexível ou sensação de “mente acelerada” no fim do dia. Convém diferenciar insônia ligada ao ritmo do medicamento de hiperativação ansiosa habitual, uso tardio, consumo de cafeína e piora global do quadro.

Irritabilidade e reatividade: Alguns pacientes descrevem mais impaciência, respostas curtas ou sensação de estar “no limite”, especialmente em transições do dia ou quando estão sem comer e cansados. Na sessão, isso pode ser confundido com aumento de agressividade, piora do humor ou tensão transferencial, quando às vezes o fenômeno é mais situacional e temporal. Observar se a irritabilidade é nova, se aparece em janelas previsíveis e se vem junto de queda de foco ou desconforto corporal ajuda a separar efeito do medicamento, estresse ambiental e desregulação já presente antes.

Ansiedade ou ativação: Em parte dos pacientes, o ganho de energia e prontidão pode ser vivido como melhora; em outros, como inquietação, aperto interno ou aceleração difícil de nomear. O risco clínico na terapia é tomar toda ativação por ansiedade de base, ou o contrário, supor benefício quando o paciente está mais tenso e menos capaz de elaborar. A distinção costuma depender de perguntar se a pessoa está mais funcional e centrada ou apenas mais rápida, mais vigilante e menos tolerante ao próprio desconforto.

Adesão e uso irregular: Com metilfenidato, o padrão de uso frequentemente entra no campo terapêutico: esquecer, evitar em certos dias, usar só para estudar ou trabalhar, interromper em fins de semana, ou omitir o uso por receio de julgamento. Isso pode produzir sessões muito diferentes entre si e confundir a leitura de progresso, motivação e capacidade de insight. Vale mapear regularidade, contexto de uso e razões subjetivas para tomar ou não tomar, porque a irregularidade às vezes explica mais a oscilação clínica do que uma mudança do quadro de base.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O cloridrato de metilfenidato é um estimulante usado sobretudo em TDAH e, em alguns casos, em quadros com desatenção e lentificação importantes. No consultório, o mais útil é acompanhar o padrão temporal: parte dos efeitos percebidos aparece já nos primeiros dias, enquanto o ajuste subjetivo da rotina pode levar algumas semanas; também vale observar diferenças entre manhã, tarde e noite e entre dias de uso regular e irregular. O foco clínico costuma ser menos “se está funcionando” em abstrato e mais como atenção, impulsividade, apetite, sono, irritabilidade e vínculo com tarefas oscilam ao longo do dia e interferem na sessão.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais focado, isso vem junto com mais clareza e organização ou com uma sensação de pressa e tensão por dentro? , Nos dias em que você dorme pior, a dificuldade é desligar a mente à noite ou o problema começa antes, com cansaço, preocupação ou rotina desorganizada? , Essa irritação aparece de modo mais espalhado ao longo da semana ou em horários mais previsíveis do dia, especialmente quando você está sem comer ou no fim do efeito percebido? , Quando sua sessão rende menos, isso se parece com desatenção habitual sua ou com uma oscilação mais marcada entre um horário e outro do mesmo dia? , Nos dias em que você não usa ou usa de outro jeito, o que muda mais: foco, humor, apetite, sono ou sua disposição para tarefas? , Essa melhora que você nota aumenta também sua capacidade de sustentar conversa, escutar e elaborar, ou você se sente apenas mais produtivo e acelerado?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a alternar dias de uso e não uso com impacto claro em humor
- foco ou sono
- pode valer alinhar com o médico assistente para contextualizar a oscilação clínica e o risco de abandono silencioso
- Quando surgem perda de apetite persistente
- emagrecimento percebido ou recusa frequente de refeições com repercussão no funcionamento
- pode valer comunicar o médico para avaliação da tolerabilidade
- Quando a sessão passa a mostrar irritabilidade nova
- inquietação importante ou piora consistente do sono após o início do tratamento
- pode valer alinhar com o médico para discriminar efeito do medicamento de evolução do quadro
- Quando não há mudança funcional perceptível após algumas semanas de uso regular
- apesar de boa adesão referida
- pode valer comunicar o médico para informar a ausência de benefício observável no cotidiano
- Quando o paciente relata uso instrumental
- escondido ou muito irregular por vergonha
- ambivalência ou pressão de desempenho

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico porque esse padrão interfere diretamente na leitura clínica e na continuidade do tratamento

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem fala muito acelerada
- redução acentuada da necessidade de sono
- expansividade incomum
- impulsividade e sensação de estar “bom demais” de modo claramente fora da linha de base.: Tratar como possível virada de humor
- acionar o médico assistente no mesmo dia e ampliar avaliação de risco e rede de apoio
- O paciente chega muito agitado
- confuso
- com mal-estar importante
- tremores marcados ou comportamento desorganizado que foge nitidamente do padrão habitual.: Interromper o foco interpretativo
- avaliar segurança imediata e acionar atendimento médico urgente conforme a gravidade e a rede disponível
- Surge ideação suicida nova ou intensificada
- especialmente se acompanhada de agitação
- impulsividade ou piora abrupta do sono e da irritabilidade.: Fazer manejo de risco no mesmo atendimento
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

Com metilfenidato, o essencial é ler a oscilação ao longo do dia e separar foco melhorado de ativação, irritabilidade, insônia e uso irregular.

133 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA

Substância: Dimesilato de Lisdexanfetamina.

Nomes Comerciais: Lysdexa, Dimesilato de Lisdexanfetamina, Lisdev, Lind, Lyberdia, Lyberdia Gotas, Deksa, Lidexor, Lidexor Gotas, Juneve, Venvanse, Vimade, Lisvenx, Dexxah, Monitum

Uso comum

- O dimesilato de lisdexanfetamina é um estimulante do SNC usado sobretudo em TDAH e, em alguns contextos, em compulsão alimentar. No consultório, costuma aparecer mais pela mudança no ritmo subjetivo do dia do que por uma “melhora global” imediata: nas primeiras 1 a 2 semanas vale observar ativação, piora de ansiedade, redução de apetite e impacto no sono; ao longo de 2 a 6 semanas tende a ficar mais claro se houve ganho funcional sustentado em atenção, organização e manejo da impulsividade. O ponto central na sessão é diferenciar benefício real em autorregulação de um estado de aceleração, além de mapear oscilações ao longo do dia e adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Ativação e ansiedade:** Alguns pacientes chegam mais rápidos, objetivos e produtivos, enquanto outros descrevem tensão interna, irritabilidade ou sensação de estar "ligado demais", sobretudo no início ou em dias de retomada irregular. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais pressionada, menor tolerância à pausa e dificuldade de permanecer em elaboração mais lenta. A leitura pode se confundir com ansiedade basal, estresse recente, consumo de cafeína ou alívio inicial por finalmente conseguir render; o discriminador costuma estar no contraste com a linha de base e no horário em que a ativação aparece e cede.

Atenção e organização: Quando há benefício clínico, o paciente tende a relatar menos dispersão, maior capacidade de iniciar e concluir tarefas e menor custo subjetivo para sustentar foco. Em sessão, isso pode se traduzir em narrativa mais sequenciada, melhor memória do intervalo entre encontros e maior capacidade de acompanhar o fio associativo sem se perder. Ainda assim, melhora pontual de desempenho não equivale necessariamente a mudança estável do funcionamento: pressão externa, novidade, maior estrutura ambiental ou desejo de corresponder ao tratamento também podem produzir um período de aparente ganho.

Oscilação ao longo do dia: Uma pista frequente é a diferença entre como o paciente fica em certos horários e como chega à sessão dependendo do turno. Alguns descrevem uma faixa do dia em que funcionam melhor e outra em que reaparecem distração, irritabilidade, cansaço ou sensação de "queda", o que pode ser confundido com instabilidade emocional primária. Vale observar se a oscilação é previsível e repetitiva, porque isso ajuda a distinguir efeito temporal do medicamento de variações ligadas a conflitos, frustração ou privação de sono.

Sono: Dificuldade para desacelerar à noite, atraso para dormir ou sono mais curto podem surgir, especialmente nas primeiras semanas, e às vezes o paciente só percebe isso indiretamente pelo aumento de cansaço, impaciência ou labilidade no fim do dia. Em sessão, a privação de sono pode imitar piora de humor, ansiedade ou até aparente "ineficácia" do tratamento por queda de rendimento. Também é comum confundir um padrão antigo de sono desorganizado com algo novo; por isso, comparar com a baseline e com a rotina recente costuma ser mais útil do que tomar a queixa isoladamente.

Apetite e peso: Redução de fome durante parte do dia é um tema recorrente e pode aparecer como esquecimento de comer, menor prazer alimentar ou alimentação concentrada em horários tardios. No consultório, isso às vezes surge não como queixa principal, mas como irritabilidade, cefaleia, queda de energia ou maior rigidez cognitiva em sessões mais longas. A leitura clínica pode se embaralhar com dieta, imagem corporal, rotina corrida ou compulsão alimentar prévia; vale discriminar se houve mudança concreta no padrão de refeições desde o início do uso.

Humor e impulsividade: Em alguns casos há menos reatividade, menos interrupções e maior capacidade de frear impulsos; em outros, aparece irritabilidade, impaciência ou um bem-estar acelerado que não corresponde exatamente a regulação emocional. Na sessão, o terapeuta pode notar maior controle executivo sem aumento proporcional de elaboração afetiva, ou, ao contrário, uma expansividade pouco habitual. Isso pode se confundir com melhora genuína por redução do caos atencional, com traços temperamentais, com uso irregular ou, em pacientes vulneráveis, com uma virada de humor que merece atenção.

Adesão e uso irregular: Por ser um medicamento cujo efeito costuma ser percebido no próprio cotidiano, não é raro o paciente alternar dias de uso, “testar” sozinho situações específicas ou omitir interrupções por considerar isso detalhe menor. Em sessão, essa irregularidade pode produzir relatos contraditórios: dias muito produtivos seguidos de queda importante, oscilação de apetite e sono, ou impressão de que o tratamento “funciona só às vezes”. Antes de concluir perda de resposta ou agravamento do quadro, costuma ser útil mapear com precisão a regularidade do uso e o contexto dos dias em que o padrão muda.”

O que observar em sessão

- **Ativação e ansiedade:** Alguns pacientes chegam mais rápidos, objetivos e produtivos, enquanto outros descrevem tensão interna, irritabilidade ou sensação de estar “ligado demais”, sobretudo no início ou em dias de retomada irregular. Na sessão, isso pode aparecer como fala mais pressionada, menor tolerância à pausa e dificuldade de permanecer em elaboração mais lenta. A leitura pode se confundir com ansiedade basal, estresse recente, consumo de cafeína ou alívio inicial por finalmente conseguir render; o discriminador costuma estar no contraste com a linha de base e no horário em que a ativação aparece e cede.

Atenção e organização: Quando há benefício clínico, o paciente tende a relatar menos dispersão, maior capacidade de iniciar e concluir tarefas e menor custo subjetivo para sustentar foco. Em sessão, isso pode se traduzir em narrativa mais sequenciada, melhor memória do intervalo entre encontros e maior capacidade de acompanhar o fio associativo sem se perder. Ainda assim, melhora pontual de desempenho não equivale necessariamente a mudança estável do funcionamento: pressão externa, novidade, maior estrutura ambiental ou desejo de corresponder ao tratamento também podem produzir um período de aparente ganho.

Oscilação ao longo do dia: Uma pista frequente é a diferença entre como o paciente fica em certos horários e como chega à sessão dependendo do turno. Alguns descrevem uma faixa do dia em que funcionam melhor e outra em que reaparecem distração, irritabilidade, cansaço ou sensação de “queda”, o que pode ser confundido com instabilidade emocional primária. Vale observar se a oscilação é previsível e repetitiva, porque isso ajuda a distinguir efeito temporal do medicamento de variações ligadas a conflitos, frustração ou privação de sono.

Sono: Dificuldade para desacelerar à noite, atraso para dormir ou sono mais curto podem surgir, especialmente nas primeiras semanas, e às vezes o paciente só percebe isso indiretamente pelo aumento de cansaço, impaciência ou labilidade no fim do dia. Em sessão, a privação de sono pode imitar piora de humor, ansiedade ou até aparente “ineficácia” do tratamento por queda de rendimento. Também é comum confundir um padrão antigo de sono desorganizado com algo novo; por isso, comparar com a baseline e com a rotina recente costuma ser mais útil do que tomar a queixa isoladamente.

Apetite e peso: Redução de fome durante parte do dia é um tema recorrente e pode aparecer como esquecimento de comer, menor prazer alimentar ou alimentação concentrada em horários tardios. No consultório, isso às vezes surge não como queixa principal, mas como irritabilidade, cefaleia, queda de energia ou maior rigidez cognitiva em sessões mais longas. A leitura clínica pode se embaralhar com dieta, imagem corporal, rotina corrida ou compulsão alimentar prévia; vale discriminar se houve mudança concreta no padrão de refeições desde o início do uso.

Humor e impulsividade: Em alguns casos há menos reatividade, menos interrupções e maior capacidade de frear impulsos; em outros, aparece irritabilidade, impaciência ou um bem-estar acelerado que não corresponde exatamente a regulação emocional. Na sessão, o terapeuta pode notar maior controle executivo sem aumento proporcional de elaboração afetiva, ou, ao contrário, uma expansividade pouco habitual. Isso pode se confundir com melhora genuína por redução do caos atencional, com traços temperamentais, com uso irregular ou, em pacientes vulneráveis, com uma virada de humor que merece atenção.

Adesão e uso irregular: Por ser um medicamento cujo efeito costuma ser percebido no próprio cotidiano, não é raro o paciente alternar dias de uso, “testar” sozinho situações específicas ou omitir interrupções por considerar isso detalhe menor. Em sessão, essa irregularidade pode produzir relatos contraditórios: dias muito produtivos seguidos de queda importante, oscilação de apetite e sono, ou impressão de que o tratamento “funciona só às vezes”. Antes de concluir perda de resposta ou agravamento do quadro, costuma ser útil mapear com precisão a regularidade do uso e o contexto dos dias em que o padrão muda.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O dimesilato de lisdexanfetamina é um estimulante do SNC usado sobretudo em TDAH e, em alguns contextos, em compulsão alimentar. No consultório, costuma aparecer mais pela mudança no ritmo subjetivo do dia do que por uma “melhora global” imediata: nas primeiras 1 a 2 semanas vale observar ativação, piora de ansiedade, redução de apetite e impacto no sono; ao longo de 2 a 6 semanas tende a ficar mais claro se houve ganho funcional sustentado em atenção, organização e manejo da impulsividade. O ponto central na sessão é diferenciar benefício real em autorregulação de um estado de aceleração, além de mapear oscilações ao longo do dia e adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que ficou mais produtivo, isso veio junto com mais clareza e constância ou com uma sensação de pressa e tensão no corpo? , Nos dias em que você se sente pior ou mais irritado, isso parece ligado a algum horário do dia, a noites mal dormidas ou a situações emocionais específicas? , A melhora que você percebeu aparece também em tarefas chatas e repetitivas, ou mais em momentos de urgência e cobrança externa? , Quando seu apetite muda, você deixa de sentir fome ao longo do dia ou acaba pulando refeições por estar hiperfocado e só percebe depois? , Esse estado de mais energia veio com maior capacidade de se organizar ou com menos necessidade de dormir, mais impulsividade e sensação de estar diferente do seu padrão habitual? , Nas semanas em que o efeito parece inconsistente, houve dias sem tomar, horários muito variáveis ou mudanças grandes na rotina?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve benefício parcial
- mas com ansiedade
- irritabilidade ou insônia persistentes após as primeiras semanas
- pode valer alinhar com o médico assistente para qualificar tolerabilidade e impacto funcional
- Quando surgem oscilações muito marcadas ao longo do dia
- com períodos previsíveis de queda
- irritabilidade ou piora importante do funcionamento
- pode valer comunicar para contextualizar o padrão observado na terapia
- Quando a redução de apetite começa a repercutir em perda de peso percebida

Amarelo: alinhar em breve

- alimentação muito irregular ou sofrimento relevante em torno de comer
- pode valer contato com o médico pela repercussão clínica e risco de abandono silencioso
- Quando o paciente alterna dias de uso
- interrompe por conta própria ou usa apenas em situações específicas e isso embaralha a leitura do quadro
- pode valer alinhar com o médico para informar a irregularidade observada
- Quando aparece aceleração incomum
- expansividade
- impulsividade aumentada ou redução importante da necessidade de sono em alguém sem esse padrão de base
- pode valer comunicação breve com o médico para discutir possível mudança de estado de humor

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente aparece muito acelerado
- com fala difícil de interromper
- grandiosidade incomum
- impulsividade acentuada e quase sem necessidade de dormir nos últimos dias.: Tratar como mudança aguda de estado
- acionar o médico no mesmo dia e mobilizar rede de apoio e avaliação de urgência se houver risco comportamental
- Surge ideação suicida nova ou nitidamente intensificada
- especialmente se acompanhada de agitação
- desesperança ou piora abrupta do autocontrole.: Fazer avaliação de risco imediata
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- recorrendo à emergência quando necessário
- O paciente relata mal-estar intenso com agitação importante
- tremores marcados
- confusão
- sensação de corpo “descompassado” ou piora física aguda durante a sessão.: Interromper o foco interpretativo
- priorizar avaliação clínica imediata e encaminhamento para atendimento médico urgente

Frase clínica

O foco é distinguir ganho real de autorregulação de aceleração, ansiedade e oscilações do dia que podem embaralhar a leitura clínica.

134 MODAFINILA

Substância: Modafinila.

Nomes Comerciais: Stavigile

Uso comum

- Modafinila é um agente promotor de vigília que costuma aparecer em pacientes com sonolência diurna importante e, às vezes, em contextos de busca de rendimento ou manutenção de funcionamento. Na terapia, o mais útil é acompanhar se houve mudança consistente em alerta, ritmo de fala, tolerância ao tédio, irritabilidade e padrão de sono nas primeiras 1 a 3 semanas, além de observar oscilações ao longo do dia e uso irregular. Quando há benefício, ele tende a surgir cedo; quando o paciente alterna dias de uso ou usa em horários variáveis, a leitura clínica pode se confundir com privação de sono, ansiedade de base, sobrecarga ou tentativa de compensar exaustão crônica.

O paciente pode relatar

- **"Vigília e ritmo:** Alguns pacientes chegam mais despertos, com maior prontidão cognitiva e menos lentificação, o que pode favorecer presença em sessão e capacidade de elaboração. Em outros, aparece um estado mais tenso, apressado ou pouco tolerante a pausas, que pode se parecer com melhora de energia quando na verdade há apenas aumento de ativação. Vale comparar com a linha de base e com o padrão fora da sessão, porque noites ruins, turnos de trabalho, apneia do sono, uso de cafeína e recuperação parcial de exaustão também alteram muito esse eixo.

Sono noturno: Uma pista clínica frequente é a reorganização do ciclo sono-vigília: o paciente pode relatar menos cochilos e mais funcionamento diurno, mas também dificuldade para desacelerar à noite ou sono mais curto. Na sessão, isso às vezes aparece como alerta excessivo, impaciência ou oscilação entre produtividade e cansaço acumulado. A leitura fica confusa quando já havia insônia prévia, rotina irregular, uso de telas até tarde ou tentativa de compensar privação de sono com a medicação.

Ansiedade e irritabilidade: Em parte dos pacientes, maior vigília vem acompanhada de inquietação subjetiva, sensação de estar "ligado", irritabilidade ou menor margem para frustração. Isso pode ser confundido com ansiedade habitual, estresse ocupacional ou traços de personalidade mais controladores, especialmente se o ganho funcional inicial for valorizado pelo paciente. Observar se a tensão aparece em janelas previsíveis após o uso, se piora em dias de maior demanda e se coexistem fala acelerada, impaciência corporal ou redução do sono ajuda a discriminar.

Foco e desempenho: O paciente pode descrever mais concentração, persistência em tarefas e menor dispersão, mas também hiperfoco pouco flexível, dificuldade de alternar atenção ou produtividade com custo subjetivo alto. Na sessão, isso pode surgir como discurso mais objetivo e eficiente ou, ao contrário, como rigidez, pressa para "render" e menor acesso associativo. Convém diferenciar melhora real de atenção de um funcionamento mais estreito, sustentado por cobrança, perfeccionismo ou uso instrumental para atravessar sobrecarga.

Uso instrumental: Como a modafinila pode ser incorporada ao cotidiano como recurso para estudar, trabalhar ou compensar fadiga, às vezes o tema central não é um efeito isolado, mas a relação do paciente com desempenho, limites corporais e autoexigência. O terapeuta pode notar orgulho do ganho funcional, ambivalência sobre depender de algo para produzir ou silêncio sobre dias em que evita usar e "desaba". Isso se mistura facilmente com cultura de alta performance, burnout, privação crônica de sono e dificuldade de reconhecer sinais de esgotamento."

O que observar em sessão

- **Vigília e ritmo:** Alguns pacientes chegam mais despertos, com maior prontidão cognitiva e menos lentificação, o que pode favorecer presença em sessão e capacidade de elaboração. Em outros, aparece um estado mais tenso, apressado ou pouco tolerante a pausas, que pode se parecer com melhora de energia quando na verdade há apenas aumento de ativação. Vale comparar com a linha de base e com o padrão fora da sessão, porque noites ruins, turnos de trabalho, apneia do sono, uso de cafeína e recuperação parcial de exaustão também alteram muito esse eixo.

Sono noturno: Uma pista clínica frequente é a reorganização do ciclo sono-vigília: o paciente pode relatar menos cochilos e mais funcionamento diurno, mas também dificuldade para desacelerar à noite ou sono mais curto. Na sessão, isso às vezes aparece como alerta excessivo, impaciência ou oscilação entre produtividade e cansaço acumulado. A leitura fica confusa quando já havia insônia prévia, rotina irregular, uso de telas até tarde ou tentativa de compensar privação de sono com a medicação.

Ansiedade e irritabilidade: Em parte dos pacientes, maior vigília vem acompanhada de inquietação subjetiva, sensação de estar “ligado”, irritabilidade ou menor margem para frustração. Isso pode ser confundido com ansiedade habitual, estresse ocupacional ou traços de personalidade mais controladores, especialmente se o ganho funcional inicial for valorizado pelo paciente. Observar se a tensão aparece em janelas previsíveis após o uso, se piora em dias de maior demanda e se coexistem fala acelerada, impaciência corporal ou redução do sono ajuda a discriminar.

Foco e desempenho: O paciente pode descrever mais concentração, persistência em tarefas e menor dispersão, mas também hiperfoco pouco flexível, dificuldade de alternar atenção ou produtividade com custo subjetivo alto. Na sessão, isso pode surgir como discurso mais objetivo e eficiente ou, ao contrário, como rigidez, pressa para “render” e menor acesso associativo. Convém diferenciar melhora real de atenção de um funcionamento mais estreito, sustentado por cobrança, perfeccionismo ou uso instrumental para atravessar sobrecarga.

Uso instrumental: Como a modafinila pode ser incorporada ao cotidiano como recurso para estudar, trabalhar ou compensar fadiga, às vezes o tema central não é um efeito isolado, mas a relação do paciente com desempenho, limites corporais e autoexigência. O terapeuta pode notar orgulho do ganho funcional, ambivalência sobre depender de algo para produzir ou silêncio sobre dias em que evita usar e “desaba”. Isso se mistura facilmente com cultura de alta performance, burnout, privação crônica de sono e dificuldade de reconhecer sinais de esgotamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Modafinila é um agente promotor de vigília que costuma aparecer em pacientes com sonolência diurna importante e, às vezes, em contextos de busca de rendimento ou manutenção de funcionamento. Na terapia, o mais útil é acompanhar se houve mudança consistente em alerta, ritmo de fala, tolerância ao tédio, irritabilidade e padrão de sono nas primeiras 1 a 3 semanas, além de observar oscilações ao longo do dia e uso irregular. Quando há benefício, ele tende a surgir cedo; quando o paciente alterna dias de uso ou usa em horários variáveis, a leitura clínica pode se confundir com privação de sono, ansiedade de base, sobrecarga ou tentativa de compensar exaustão crônica.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente melhor com ela, isso parece uma melhora estável do seu funcionamento ou um estado mais acelerado, em que fica difícil desacelerar depois? , Nos dias em que você usa, o que muda primeiro: o sono, a irritação, a concentração ou a disposição para tarefas? , Essa sensação de estar mais ligado vem com clareza e organização ou com pressa, impaciência e menor tolerância a pausas? , Quando você dorme mal, o efeito no dia seguinte parece compensar o cansaço ou acaba empurrando você além do seu limite? , Nos dias em que não usa ou usa em rotina diferente, o que muda no seu humor e no seu rendimento em comparação com os outros dias?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a dormir menos por vários dias e chega mais acelerado
- irritável ou grandioso do que sua linha de base
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se houve mudança clínica relevante além de ganho de vigília
- Quando a melhora de alerta vem acompanhada de ansiedade
- inquietação ou irritabilidade que começa a comprometer vínculo
- trabalho ou sono
- pode valer comunicar para avaliação da tolerabilidade clínica
- Quando o paciente usa de modo irregular
- alterna conforme demanda ou omite dias de uso e isso embaralha a leitura do quadro
- pode valer alinhar com o médico para contextualizar a oscilação observada
- Quando não há ganho funcional perceptível após as primeiras semanas
- apesar de uso referido como regular
- pode valer comunicar para situar a ausência de benefício observável na rotina e na sessão
- Quando o paciente passa a usar a medicação como principal forma de sustentar jornadas incompatíveis com descanso básico
- pode valer contato com o médico assistente porque o padrão pode mascarar exaustão importante e aumentar sofrimento

Vermelho: tratar como urgência

- Surge redução importante da necessidade de sono junto de fala muito acelerada
- expansividade incomum
- impulsividade ou sensação de invulnerabilidade fora do padrão do paciente.: Tratar como mudança aguda de estado
- acionar o médico assistente no mesmo dia e mobilizar rede de apoio se houver risco comportamental
- Aparecem ideias de morte
- autoagressão ou piora abrupta de desesperança em paralelo a mudança recente no uso ou no estado de ativação.: Fazer avaliação de risco na sessão
- acionar suporte imediato e contatar o médico assistente no mesmo dia; recorrer à emergência se o risco não puder ser contido

Frase clínica

O foco clínico é distinguir ganho de vigília de ativação excessiva, especialmente quando sono, irritabilidade e desempenho começam a se desorganizar.

135 BROMAZEPAM;SULPIRIDA

Substância: Bromazepam;Sulpirida.

Nomes Comerciais: Sulpan

Uso comum

- Combinação de benzodiazepínico com antipsicótico em baixa dose, encontrada em contextos de ansiedade intensa, insônia, agitação, queixas somáticas com forte componente ansioso e, às vezes, uso prolongado já incorporado à rotina do paciente. Nas primeiras horas a dias, o que mais tende a aparecer em sessão é redução de tensão com lentificação, sonolência ou menor acesso associativo; ao longo de semanas, vale observar se houve ganho funcional real ou apenas amortecimento do sofrimento. Em uso contínuo, a leitura clínica costuma depender de baseline, horário de tomada e regularidade do uso. Mudanças abruptas após faltas, interrupções ou retomadas podem confundir-se com piora do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sedação clínica:** Em sessão, o paciente pode chegar mais lento, com fala menos espontânea, menor iniciativa associativa e aparência de cansaço, às vezes descrevendo alívio da tensão ao custo de embotamento ou dificuldade de se manter presente. Isso pode ser lido apressadamente como melhora da ansiedade, quando em parte pode haver apenas redução de reatividade com queda de vigília. Também convém diferenciar de privação de sono, episódio depressivo, uso de álcool ou outras medicações sedativas, além de notar se o padrão varia conforme o horário da sessão e da tomada.

Ansiedade e agitação: Alguns pacientes relatam diminuição rápida da inquietação e da urgência interna, enquanto outros seguem ansiosos, mas menos capazes de nomear ou elaborar o que sentem. Na sessão, isso pode aparecer como menor descarga motora sem correspondente ampliação de reflexão, o que às vezes mascara manutenção do conflito ou agravamento por eventos de vida recentes. Quando a ansiedade oscila muito entre sessões, vale considerar adesão irregular, uso sob demanda, cafeína, álcool e mudanças contextuais antes de atribuir a variação ao medicamento.

Cognição e elaboração: Pode surgir dificuldade de concentração, memória recente mais falha, encadeamento menos nítido e menor capacidade de sustentar exploração emocional mais fina. O terapeuta pode notar respostas mais concretas, perda do fio da narrativa ou necessidade de repetir perguntas, especialmente se a sessão ocorre em período de maior efeito subjetivo. Esse quadro pode se confundir com ansiedade alta, exaustão, depressão, dor crônica ou sobrecarga de vida, por isso ajuda comparar com a linha de base anterior ao início ou às mudanças de uso.

Adesão e oscilação: Em combinações com componente benzodiazepínico, não é raro que o uso real se afaste do uso prescrito, com esquecimentos, tomadas extras em dias difíceis ou interrupções silenciosas quando o paciente se sente melhor ou excessivamente sonolento. Na terapia, isso costuma aparecer como sessões muito diferentes entre si: em uma, o paciente está amortecido; em outra, mais tenso, irritável ou insone. Sem explorar a regularidade do uso e o contexto dessas oscilações, o terapeuta pode confundir descontinuidade, rebote ansioso ou efeito de rotina com instabilidade do quadro psíquico.

Acesso afetivo: Parte dos pacientes descreve alívio por finalmente conseguir descansar da tensão; outra parte percebe distância afetiva, menor vivacidade emocional ou sensação de estar funcionando no automático. Em sessão, o ponto não é apenas se a angústia caiu, mas se houve recuperação de capacidade de pensar, sentir e escolher com mais liberdade. Esse amortecimento pode ser confundido com melhora clínica, defesa dissociativa diante de estressores ou retraimento depressivo, especialmente quando o paciente valoriza muito o simples fato de sofrer menos.

Sinais físicos relevantes: Além do efeito sedativo, podem aparecer queixas como inquietação corporal difícil de nomear, rigidez subjetiva, sensação de corpo estranho ou desconforto motor que o paciente chama de nervosismo. Na sessão, isso merece atenção porque pode ser confundido com ansiedade habitual ou agitação por conflito emocional, quando o padrão corporal e a temporalidade sugerem outra origem. Mudanças em sono, apetite, sexualidade e disposição também podem entrar no relato, mas ganham sentido clínico sobretudo quando

surgem junto de alteração nítida do padrão corporal e funcional."

O que observar em sessão

- **Sedação clínica:** Em sessão, o paciente pode chegar mais lento, com fala menos espontânea, menor iniciativa associativa e aparência de cansaço, às vezes descrevendo alívio da tensão ao custo de embotamento ou dificuldade de se manter presente. Isso pode ser lido apressadamente como melhora da ansiedade, quando em parte pode haver apenas redução de reatividade com queda de vigília. Também convém diferenciar de privação de sono, episódio depressivo, uso de álcool ou outras medicações sedativas, além de notar se o padrão varia conforme o horário da sessão e da tomada.

Ansiedade e agitação: Alguns pacientes relatam diminuição rápida da inquietação e da urgência interna, enquanto outros seguem ansiosos, mas menos capazes de nomear ou elaborar o que sentem. Na sessão, isso pode aparecer como menor descarga motora sem correspondente ampliação de reflexão, o que às vezes mascara manutenção do conflito ou agravamento por eventos de vida recentes. Quando a ansiedade oscila muito entre sessões, vale considerar adesão irregular, uso sob demanda, cafeína, álcool e mudanças contextuais antes de atribuir a variação ao medicamento.

Cognição e elaboração: Pode surgir dificuldade de concentração, memória recente mais falha, encadeamento menos nítido e menor capacidade de sustentar exploração emocional mais fina. O terapeuta pode notar respostas mais concretas, perda do fio da narrativa ou necessidade de repetir perguntas, especialmente se a sessão ocorre em período de maior efeito subjetivo. Esse quadro pode se confundir com ansiedade alta, exaustão, depressão, dor crônica ou sobrecarga de vida, por isso ajuda comparar com a linha de base anterior ao início ou às mudanças de uso.

Adesão e oscilação: Em combinações com componente benzodiazepínico, não é raro que o uso real se afaste do uso prescrito, com esquecimentos, tomadas extras em dias difíceis ou interrupções silenciosas quando o paciente se sente melhor ou excessivamente sonolento. Na terapia, isso costuma aparecer como sessões muito diferentes entre si: em uma, o paciente está amortecido; em outra, mais tenso, irritável ou insone. Sem explorar a regularidade do uso e o contexto dessas oscilações, o terapeuta pode confundir descontinuidade, rebote ansioso ou efeito de rotina com instabilidade do quadro psíquico.

Acesso afetivo: Parte dos pacientes descreve alívio por finalmente conseguir descansar da tensão; outra parte percebe distância afetiva, menor vivacidade emocional ou sensação de estar funcionando no automático. Em sessão, o ponto não é apenas se a angústia caiu, mas se houve recuperação de capacidade de pensar, sentir e escolher com mais liberdade. Esse amortecimento pode ser confundido com melhora clínica, defesa dissociativa diante de estressores ou retraimento depressivo, especialmente quando o paciente valoriza muito o simples fato de sofrer menos.

Sinais físicos relevantes: Além do efeito sedativo, podem aparecer queixas como inquietação corporal difícil de nomear, rigidez subjetiva, sensação de corpo estranho ou desconforto motor que o paciente chama de nervosismo. Na sessão, isso merece atenção porque pode ser confundido com ansiedade habitual ou agitação por conflito emocional, quando o padrão corporal e a temporalidade sugerem outra origem. Mudanças em sono, apetite, sexualidade e disposição também podem entrar no relato, mas ganham sentido clínico sobretudo quando

surtem junto de alteração nítida do padrão corporal e funcional.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Combinação de benzodiazepínico com antipsicótico em baixa dose, encontrada em contextos de ansiedade intensa, insônia, agitação, queixas somáticas com forte componente ansioso e, às vezes, uso prolongado já incorporado à rotina do paciente. Nas primeiras horas a dias, o que mais tende a aparecer em sessão é redução de tensão com lentificação, sonolência ou menor acesso associativo; ao longo de semanas, vale observar se houve ganho funcional real ou apenas amortecimento do sofrimento. Em uso contínuo, a leitura clínica costuma depender de baseline, horário de tomada e regularidade do uso. Mudanças abruptas após faltas, interrupções ou retomadas podem confundir-se com piora do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está mais calmo, isso veio junto com mais clareza para pensar e decidir ou mais como um apagamento da tensão? , Nos dias em que você chega mais sonolento ou lento, isso costuma acontecer em horários parecidos ou depois de alguma mudança na rotina de uso? , Essa inquietação no corpo parece a sua ansiedade de costume, com pensamentos e preocupações, ou é mais uma sensação física de não conseguir ficar parado mesmo sem um motivo claro? , Quando sua semana oscila muito, você percebe relação com noites mal dormidas, eventos da semana ou com dias em que tomou diferente do habitual? , A dificuldade de falar de si e elaborar aqui na sessão parece vir de tristeza e desânimo, ou de uma sensação de cabeça mais lenta e menos disponível? , Quando você se sente melhor, isso aparece como retomada de interesse e presença na vida ou mais como ficar menos afetado pelas coisas?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sedado
- com prejuízo claro de funcionamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se o padrão coincide com o tratamento em uso ou com outra intercorrência
- Quando surgem oscilações marcantes entre sessões associadas a esquecimentos
- interrupções ou uso fora da rotina
- pode valer comunicar o médico para reduzir confusão entre adesão irregular e piora do quadro de base
- Quando aparece inquietação corporal nova
- persistente e pouco compatível com a ansiedade habitual do paciente
- pode valer contato com o médico assistente pela possibilidade de efeito que esteja comprometendo adesão e conforto
- Quando o paciente descreve embotamento importante
- perda de iniciativa ou sensação de estar 'anestesiado' a ponto de abandonar atividades e vínculos

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico pela repercussão funcional e risco de abandono silencioso do tratamento
- Quando não há ganho funcional perceptível após algumas semanas e a sessão mostra apenas amortecimento ou manutenção do sofrimento sob menor expressão
- pode valer comunicar o médico para compartilhar a evolução clínica observada

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente apresenta rebaixamento importante de consciência
- muita dificuldade para se manter acordado
- desorientação ou fala muito desconexa durante a sessão.: Interromper o trabalho interpretativo
- avaliar segurança imediata
- acionar rede de apoio e buscar avaliação médica no mesmo dia; emergência se houver risco clínico
- Aparecem ideias suicidas com intenção
- plano ou perda importante de controle
- especialmente em contexto de piora abrupta
- desorganização ou uso irregular.: Manejar como urgência clínica hoje
- acionando psiquiatra
- rede de apoio e serviços de emergência quando necessário

Frase clínica

O foco é distinguir alívio da ansiedade de amortecimento, sedação e oscilação ligada ao uso real do medicamento.

136 CLORDIAZEPÓXIDO; CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA

Substância: Clordiazepóxido; Cloridrato de Amitriptilina.

Nomes Comerciais: Limbitrol

Uso comum

- Combinação de um benzodiazepínico com um antidepressivo tricíclico, encontrada em quadros com ansiedade importante associada a humor deprimido, insônia, tensão somática e sofrimento mais crônico. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o consultório pode captar sobretudo sedação, lentificação, boca seca, piora de atenção e oscilação entre alívio da tensão e sensação de embotamento; mudanças mais consistentes de humor tendem a ser acompanhadas ao longo de 2 a 6 semanas. O ponto central na sessão é distinguir redução de ansiedade de base de sonolência medicamentosa, e melhora clínica real de um funcionamento apenas mais amortecido.

O paciente pode relatar

- **"Sedação e ritmo:** Na sessão, pode aparecer fala mais lenta, maior latência de resposta, sonolência, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar elaboração mais complexa. Isso pode ser lido como alívio da ansiedade ou como piora depressiva, quando às vezes o que predomina é um efeito sedativo mais evidente no início ou após uso irregular. Vale comparar com a linha de base do paciente, com o horário em que tomou a medicação e com a variação entre sessões, porque noites mal dormidas, álcool e outras medicações também podem produzir quadro semelhante.

Ansiedade e tensão: Alguns pacientes chegam menos reativos, com menor urgência interna, menos ruminação e menos descarga corporal de ansiedade, o que pode favorecer acesso ao material clínico. Em outros, a redução da tensão convive com sensação de estar 'desligado', sem que isso represente elaboração maior ou melhora global do quadro. A leitura pode se confundir com efeito de contenção do vínculo, com eventos de vida menos estressantes naquela semana ou com uso intermitente, que produz sessões muito diferentes entre si.

Humor e embotamento: Ao longo das semanas, pode haver redução de choro, desesperança e irritabilidade, mas também um achatamento subjetivo em que o paciente sofre menos sem se sentir propriamente melhor. Na sessão, isso aparece como menor acesso afetivo, respostas mais econômicas e dificuldade de discriminar tristeza de cansaço. Diferenciar melhora depressiva de embotamento é especialmente importante quando a funcionalidade não acompanha a aparente estabilização do humor ou quando o paciente descreve alívio sem vitalidade.

Cognição e atenção: Esquecimentos, dificuldade de concentração, sensação de cabeça 'pesada' e menor agilidade mental podem surgir no relato e interferir no trabalho terapêutico. Isso pode ser confundido com piora depressiva, sobrecarga ocupacional, privação de sono ou ansiedade ainda alta, sobretudo se o paciente oscila muito de uma sessão para outra. Quando a queda cognitiva aparece junto de sedação visível ou após retomadas irregulares, a hipótese de efeito medicamentoso ganha mais peso observacional.

Sinais anticolinérgicos: Boca seca, constipação, visão turva, sensação de corpo mais 'travado' e desconforto físico podem aparecer de modo indireto, às vezes como irritabilidade, menor disposição para sair de casa ou retraimento social. Esses sinais não costumam ser o foco espontâneo da sessão, mas podem explicar mudança de humor, piora do sono e abandono silencioso do tratamento. Também aqui é fácil atribuir tudo ao quadro psíquico de base, quando o paciente está mais ocupado em lidar com o desconforto corporal do que em nomeá-lo.

Adesão e descontinuação: Por ser uma medicação que pode aliviar rapidamente a tensão em alguns pacientes e incomodar bastante em outros, a adesão irregular é uma fonte frequente de confusão clínica. O terapeuta pode notar sessões com contraste acentuado de alerta, ansiedade, sono e tolerabilidade, sem mudança proporcional nos eventos de vida. Quando o paciente reduz, interrompe ou retoma por conta própria, podem surgir piora de insônia, ansiedade rebote, mal-estar e leitura equivocada de recaída ou de 'fracasso' do tratamento."

O que observar em sessão

- **Sedação e ritmo:** Na sessão, pode aparecer fala mais lenta, maior latência de resposta, sonolência, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar elaboração mais complexa. Isso pode ser lido como alívio da ansiedade ou como piora depressiva, quando às vezes o que predomina é um efeito sedativo mais evidente no início ou após uso irregular. Vale comparar com a linha de base do paciente, com o horário em que tomou a medicação e com a variação entre sessões, porque noites mal dormidas, álcool e outras medicações também podem produzir quadro semelhante.

Ansiedade e tensão: Alguns pacientes chegam menos reativos, com menor urgência interna, menos ruminação e menos descarga corporal de ansiedade, o que pode favorecer acesso ao material clínico. Em outros, a redução da tensão convive com sensação de estar 'desligado', sem que isso represente elaboração maior ou melhora global do quadro. A leitura pode se confundir com efeito de contenção do vínculo, com eventos de vida menos estressantes naquela semana ou com uso intermitente, que produz sessões muito diferentes entre si.

Humor e embotamento: Ao longo das semanas, pode haver redução de choro, desesperança e irritabilidade, mas também um achatamento subjetivo em que o paciente sofre menos sem se sentir propriamente melhor. Na sessão, isso aparece como menor acesso afetivo, respostas mais econômicas e dificuldade de discriminar tristeza de cansaço. Diferenciar melhora depressiva de embotamento é especialmente importante quando a funcionalidade não acompanha a aparente estabilização do humor ou quando o paciente descreve alívio sem vitalidade.

Cognição e atenção: Esquecimentos, dificuldade de concentração, sensação de cabeça 'pesada' e menor agilidade mental podem surgir no relato e interferir no trabalho terapêutico. Isso pode ser confundido com piora depressiva, sobrecarga ocupacional, privação de sono ou ansiedade ainda alta, sobretudo se o paciente oscila muito de uma sessão para outra. Quando a queda cognitiva aparece junto de sedação visível ou após retomadas irregulares, a hipótese de efeito medicamentoso ganha mais peso observacional.

Sinais anticolinérgicos: Boca seca, constipação, visão turva, sensação de corpo mais 'travado' e desconforto físico podem aparecer de modo indireto, às vezes como irritabilidade, menor disposição para sair de casa ou retraimento social. Esses sinais não costumam ser o foco espontâneo da sessão, mas podem explicar mudança de humor, piora do sono e abandono silencioso do tratamento. Também aqui é fácil atribuir tudo ao quadro psíquico de base, quando o paciente está mais ocupado em lidar com o desconforto corporal do que em nomeá-lo.

Adesão e descontinuação: Por ser uma medicação que pode aliviar rapidamente a tensão em alguns pacientes e incomodar bastante em outros, a adesão irregular é uma fonte frequente de confusão clínica. O terapeuta pode notar sessões com contraste acentuado de alerta, ansiedade, sono e tolerabilidade, sem mudança proporcional nos eventos de vida. Quando o paciente reduz, interrompe ou retoma por conta própria, podem surgir piora de insônia, ansiedade rebote, mal-estar e leitura equivocada de recaída ou de 'fracasso' do tratamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Combinação de um benzodiazepínico com um antidepressivo tricíclico, encontrada em quadros com ansiedade importante associada a humor deprimido, insônia, tensão somática e sofrimento mais crônico. Nas primeiras 1 a 2 semanas, o consultório pode captar sobretudo sedação, lentificação, boca seca, piora de atenção e oscilação entre alívio da tensão e sensação de embotamento; mudanças mais consistentes de humor tendem a ser acompanhadas ao longo de 2 a 6 semanas. O ponto central na sessão é distinguir redução de ansiedade de base de sonolência medicamentosa, e melhora clínica real de um funcionamento apenas mais amortecido.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais calmo, isso vem junto de maior clareza para pensar e se implicar na sessão, ou mais como sono, lentidão e dificuldade de se conectar com o que sente? , Nos dias em que sua atenção piora, isso parece acompanhar preocupação e mente acelerada, ou aparece mais como cabeça pesada, sonolência e esquecimento? , Essa melhora do humor tem vindo com mais interesse pelas coisas e retomada da rotina, ou principalmente com menos sofrimento, mas também menos intensidade afetiva? , Quando sua semana oscila muito, essas mudanças acompanham acontecimentos claros, ou parecem variar mais conforme noites de sono, horários e regularidade com que você toma a medicação? , A dificuldade sexual ou a queda de interesse afetivo aparece como afastamento do parceiro e da relação, ou como redução mais geral de desejo e resposta corporal? , Quando você pensou em parar ou pulou doses, o que mudou primeiro: ansiedade, sono, desconfortos físicos ou sua disposição emocional?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente chega repetidamente muito sonolento
- lentificado ou com prejuízo claro de atenção que interfere no funcionamento diário
- pode valer alinhar com o psiquiatra para revisar a tolerabilidade clínica
- Quando surgem boca seca intensa
- constipação importante
- visão turva ou retenção urinária referida como motivo para querer abandonar o tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente pelo risco de interrupção silenciosa
- Quando o paciente alterna semanas de uso regular e interrupções por conta própria
- com ansiedade rebote
- insônia ou mal-estar
- pode valer alinhar com o psiquiatra para situar a adesão como variável central da leitura clínica
- Quando
- após 4 a 6 semanas
- há pouca mudança em humor e ansiedade apesar de uso aparentemente regular

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer comunicação com o médico assistente para compartilhar a ausência de resposta percebida no consultório
- Quando aparece piora importante do humor
- desesperança ou ideação suicida no início do tratamento ou após mudanças irregulares no uso
- pode valer contato mais rápido com o psiquiatra pela necessidade de reavaliação clínica

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente refere ideias de morte mais presentes
- planejamento suicida
- aumento de impulso para agir ou perda recente de freios
- sobretudo nas primeiras semanas ou após uso irregular.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar psiquiatra e rede de apoio
- e considerar emergência conforme gravidade e proteção disponível
- Há confusão importante
- fala muito desconexa
- desorientação
- queda acentuada do nível de consciência ou aparência de intoxicação.: Interromper a condução habitual da sessão e buscar avaliação médica imediata
- com apoio de acompanhante ou serviço de urgência quando necessário

Frase clínica

O foco é separar alívio da ansiedade de sedação e embotamento, sem perder de vista adesão irregular e abandono silencioso por intolerabilidade.

137 BACOPA MONNIERI (L.) WETTST.

Substância: Bacopa Monnieri (L.) Wettst..

Nomes Comerciais: Cognitus

Uso comum

- Bacopa monnieri é um fitoterápico usado com promessa de apoio à memória, atenção e desempenho cognitivo, às vezes mencionado por pacientes com queixas de estudo, envelhecimento cognitivo subjetivo ou busca de “mais foco”. No consultório, costuma aparecer mais como parte de automanejo do que como tratamento central de um transtorno mental. Quando há expectativa de benefício, ela tende a ser gradual ao longo de algumas semanas, o que torna útil acompanhar linha de base cognitiva, motivação e rotina antes de atribuir mudanças ao produto. O ponto central na sessão é diferenciar efeito percebido, efeito de expectativa, flutuação do estresse e uso irregular.

O paciente pode relatar

- **"Cognição percebida:** O paciente pode chegar dizendo que está "mais focado", "mais claro" ou, ao contrário, frustrado por não notar diferença. Na sessão, vale observar se há mudança consistente em atenção sustentada, organização do discurso e capacidade de acompanhar a conversa, ou se a melhora aparece mais como convicção do que como alteração funcional verificável. Confundem essa leitura variações de sono, sobrecarga, ansiedade de desempenho, início simultâneo de outras estratégias de estudo e o desejo de que algo finalmente funcione.

Expectativa e automanejo: Como costuma ser um produto iniciado por iniciativa própria ou por recomendação não médica, ele frequentemente entra na sessão junto com uma narrativa de autocuidado, biohacking ou tentativa de recuperar controle. Isso pode fortalecer agência, mas também gerar investimento excessivo em um recurso isolado e decepção rápida quando a rotina segue desorganizada. Mudanças subjetivas podem refletir mais esperança, placebo, disciplina recém-retomada ou redução de culpa do que um efeito específico do fitoterápico.

Ansiedade de desempenho: Em alguns pacientes, o uso aparece ligado a provas, trabalho intelectual intenso ou medo de declínio cognitivo, e a sessão passa a girar em torno de monitoramento do próprio rendimento. O terapeuta pode notar aumento de auto-observação, comparação com um ideal de produtividade e leitura catastrófica de lapsos banais. Nesses casos, a piora percebida pode acompanhar ansiedade antecipatória, perfeccionismo ou exaustão, e não necessariamente indicar efeito adverso ou ineficácia do produto.

Adesão e leitura causal: Por ser visto como "natural", o uso às vezes é irregular, intermitente ou pouco registrado pelo paciente, o que dificulta qualquer leitura temporal minimamente confiável. Na sessão, vale mapear quando começou, em que contexto usa, se há esquecimentos frequentes e em que momentos ele conclui que "funciona" ou "não funciona". Sem essa sequência, tanto melhora quanto piora podem ser atribuídas de modo apressado ao fitoterápico, quando talvez acompanhem rotina, humor, estresse ou outras substâncias em uso."

O que observar em sessão

- **Cognição percebida:** O paciente pode chegar dizendo que está “mais focado”, “mais claro” ou, ao contrário, frustrado por não notar diferença. Na sessão, vale observar se há mudança consistente em atenção sustentada, organização do discurso e capacidade de acompanhar a conversa, ou se a melhora aparece mais como convicção do que como alteração funcional verificável. Confundem essa leitura variações de sono, sobrecarga, ansiedade de desempenho, início simultâneo de outras estratégias de estudo e o desejo de que algo finalmente funcione.

Expectativa e automanejo: Como costuma ser um produto iniciado por iniciativa própria ou por recomendação não médica, ele frequentemente entra na sessão junto com uma narrativa de autocuidado, biohacking ou tentativa de recuperar controle. Isso pode fortalecer agência, mas também gerar investimento excessivo em um recurso isolado e decepção rápida quando a rotina segue desorganizada. Mudanças subjetivas podem refletir mais esperança, placebo, disciplina recém-retomada ou redução de culpa do que um efeito específico do fitoterápico.

Ansiedade de desempenho: Em alguns pacientes, o uso aparece ligado a provas, trabalho intelectual intenso ou medo de declínio cognitivo, e a sessão passa a girar em torno de monitoramento do próprio rendimento. O terapeuta pode notar aumento de auto-observação, comparação com um ideal de produtividade e leitura catastrófica de lapsos banais. Nesses casos, a piora percebida pode acompanhar ansiedade antecipatória, perfeccionismo ou exaustão, e não necessariamente indicar efeito adverso ou ineficácia do produto.

Adesão e leitura causal: Por ser visto como “natural”, o uso às vezes é irregular, intermitente ou pouco registrado pelo paciente, o que dificulta qualquer leitura temporal minimamente confiável. Na sessão, vale mapear quando começou, em que contexto usa, se há esquecimentos frequentes e em que momentos ele conclui que “funciona” ou “não funciona”. Sem essa sequência, tanto melhora quanto piora podem ser atribuídas de modo apressado ao fitoterápico, quando talvez acompanhem rotina, humor, estresse ou outras substâncias em uso.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- *Bacopa monnieri* é um fitoterápico usado com promessa de apoio à memória, atenção e desempenho cognitivo, às vezes mencionado por pacientes com queixas de estudo, envelhecimento cognitivo subjetivo ou busca de “mais foco”. No consultório, costuma aparecer mais como parte de automanejo do que como tratamento central de um transtorno mental. Quando há expectativa de benefício, ela tende a ser gradual ao longo de algumas semanas, o que torna útil acompanhar linha de base cognitiva, motivação e rotina antes de atribuir mudanças ao produto. O ponto central na sessão é diferenciar efeito percebido, efeito de expectativa, flutuação do estresse e uso irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você diz que está mais focado, isso aparece em tarefas concretas do dia a dia ou mais na sensação de estar tentando melhor? , As falhas de memória que te preocupam acontecem de modo parecido ao longo da semana ou pioram principalmente em dias de pouco sono, estresse ou pressão por desempenho? , Desde que começou a usar, houve alguma mudança observável na sua rotina de estudo, trabalho ou organização, ou a principal mudança foi na expectativa de conseguir render mais? , Nos dias em que você usa de forma mais regular, você percebe um padrão diferente do que acontece nos dias em que esquece, ou a variação parece acompanhar mais seu estado emocional e cansaço? , Quando você se frustra por não notar efeito, isso vem junto de piora objetiva no funcionamento ou de uma cobrança maior para performar sem falhas?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente associa o fitoterápico a piora nítida e persistente de humor
- ansiedade
- sono ou funcionamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar a leitura causal e o contexto de uso
- Quando há uso simultâneo de vários produtos para memória
- foco
- sono ou ansiedade e o paciente não consegue discriminar o que começou quando
- pode valer comunicação para organizar a cronologia clínica
- Quando o paciente deposita no produto a expectativa principal de resolver queda cognitiva importante
- sem melhora funcional ao longo de semanas
- pode valer alinhar com o médico para reavaliar a queixa de base
- Quando surgem efeitos incômodos que favorecem abandono silencioso ou uso muito irregular
- pode valer comunicar o médico para que a adesão real entre na formulação clínica

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem ideação suicida emergente
- desesperança acentuada ou mudança abrupta de comportamento autolesivo
- independentemente da causa presumida.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

O foco é separar melhora cognitiva funcional de expectativa, estresse e uso irregular de um fitoterápico frequentemente inserido no automanejo.

138 PIRACETAM

Substância: Piracetam.

Nomes Comerciais: Nootropil

Uso comum

- Piracetam é um agente de uso neurológico, mais associado a queixas cognitivas, vertigem, mioclonias e contextos de reabilitação do que ao manejo primário de transtornos psiquiátricos. No consultório de terapia, tende a aparecer como medicação coadjuvante em pacientes com queixas de memória, lentificação, fadiga mental ou repercussões subjetivas de uma condição neurológica. Não há uma janela clínica psicoterápica tão nítida quanto a de psicofármacos usuais; ainda assim, vale observar se mudanças em atenção, clareza mental, irritabilidade ou sono surgem nas primeiras semanas após início, retomada ou uso irregular. O foco central costuma ser distinguir efeito percebido da medicação, flutuação da condição de base e impacto emocional de viver com queixas cognitivas persistentes.

O paciente pode relatar

- **"Cognição percebida:** O paciente pode chegar mais atento, mais organizado no discurso ou, ao contrário, frustrado por não notar a melhora esperada em memória, concentração ou velocidade de raciocínio. Na sessão, vale comparar com a própria linha de base: capacidade de sustentar tema, recuperar informações recentes e acompanhar intervenções. A leitura pode se confundir facilmente com ansiedade, depressão, privação de sono, dor, sobrecarga ou expectativa excessiva depositada no remédio, especialmente quando a queixa cognitiva já vinha oscilando antes.

Agitação e irritabilidade: Em parte dos pacientes, podem aparecer inquietação, impaciência ou um tom mais reativo, que na sessão se manifesta como fala mais acelerada, menor tolerância à frustração ou dificuldade de permanecer em elaboração mais lenta. Isso pode ser lido apressadamente como traço de personalidade, piora ansiosa ou tensão situacional. Também convém considerar se houve mudança recente no padrão de uso, associação com cafeína ou outras substâncias, ou se a irritabilidade acompanha o desgaste de conviver com sintomas neurológicos e limitações funcionais.

Sono e ritmo: Alterações de sono podem entrar no consultório como dificuldade para desacelerar à noite, sono mais fragmentado ou sensação de cansaço apesar de dormir. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação de atenção, menor acesso afetivo ou irritabilidade inespecífica. Como o sono é altamente sensível a estresse, rotina, dor, idade, outras medicações e ao próprio quadro de base, vale evitar atribuição direta e observar a sequência temporal entre mudança no uso e mudança no descanso.

Adesão e uso irregular: Por não ser percebido como medicação central pelo paciente, o uso pode se tornar intermitente, silenciosamente abandonado ou retomado sem grande elaboração, sobretudo quando o benefício subjetivo parece discreto. Na sessão, isso costuma emergir como narrativa vaga sobre 'tomar quando lembra', dúvida sobre utilidade ou oscilação difícil de explicar em clareza mental e disposição. Esse ponto pode confundir a leitura do processo terapêutico, porque uma aparente piora cognitiva ou emocional pode acompanhar mais a irregularidade do uso do que uma mudança do quadro psíquico.

Carga da condição de base: Com frequência, o que mais pesa não é o medicamento em si, mas a experiência de viver com lapsos de memória, tontura, lentificação ou uma condição neurológica crônica. Isso pode aparecer como vergonha, retraimento, medo de declínio, dependência maior da família ou abalo na identidade profissional. Se o terapeuta focaliza apenas possível efeito medicamentoso, pode perder o núcleo do sofrimento: a reorganização subjetiva diante de perda de autonomia, incerteza clínica e comparação dolorosa com o funcionamento anterior."

O que observar em sessão

- **Cognição percebida:** O paciente pode chegar mais atento, mais organizado no discurso ou, ao contrário, frustrado por não notar a melhora esperada em memória, concentração ou velocidade de raciocínio. Na sessão, vale comparar com a própria linha de base: capacidade de sustentar tema, recuperar informações recentes e acompanhar intervenções. A leitura pode se confundir facilmente com ansiedade, depressão, privação de sono, dor, sobrecarga ou expectativa excessiva depositada no remédio, especialmente quando a queixa cognitiva já vinha oscilando antes.

Agitação e irritabilidade: Em parte dos pacientes, podem aparecer inquietação, impaciência ou um tom mais reativo, que na sessão se manifesta como fala mais acelerada, menor tolerância à frustração ou dificuldade de permanecer em elaboração mais lenta. Isso pode ser lido apressadamente como traço de personalidade, piora ansiosa ou tensão situacional. Também convém considerar se houve mudança recente no padrão de uso, associação com cafeína ou outras substâncias, ou se a irritabilidade acompanha o desgaste de conviver com sintomas neurológicos e limitações funcionais.

Sono e ritmo: Alterações de sono podem entrar no consultório como dificuldade para desacelerar à noite, sono mais fragmentado ou sensação de cansaço apesar de dormir. Na sessão, isso pode aparecer como oscilação de atenção, menor acesso afetivo ou irritabilidade inespecífica. Como o sono é altamente sensível a estresse, rotina, dor, idade, outras medicações e ao próprio quadro de base, vale evitar atribuição direta e observar a sequência temporal entre mudança no uso e mudança no descanso.

Adesão e uso irregular: Por não ser percebido como medicação central pelo paciente, o uso pode se tornar intermitente, silenciosamente abandonado ou retomado sem grande elaboração, sobretudo quando o benefício subjetivo parece discreto. Na sessão, isso costuma emergir como narrativa vaga sobre 'tomar quando lembra', dúvida sobre utilidade ou oscilação difícil de explicar em clareza mental e disposição. Esse ponto pode confundir a leitura do processo terapêutico, porque uma aparente piora cognitiva ou emocional pode acompanhar mais a irregularidade do uso do que uma mudança do quadro psíquico.

Carga da condição de base: Com frequência, o que mais pesa não é o medicamento em si, mas a experiência de viver com lapsos de memória, tontura, lentificação ou uma condição neurológica crônica. Isso pode aparecer como vergonha, retraimento, medo de declínio, dependência maior da família ou abalo na identidade profissional. Se o terapeuta focaliza apenas possível efeito medicamentoso, pode perder o núcleo do sofrimento: a reorganização subjetiva diante de perda de autonomia, incerteza clínica e comparação dolorosa com o funcionamento anterior.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Piracetam é um agente de uso neurológico, mais associado a queixas cognitivas, vertigem, mioclonias e contextos de reabilitação do que ao manejo primário de transtornos psiquiátricos. No consultório de terapia, tende a aparecer como medicação coadjuvante em pacientes com queixas de memória, lentificação, fadiga mental ou repercussões subjetivas de uma condição neurológica. Não há uma janela clínica psicoterápica tão nítida quanto a de psicofármacos usuais; ainda assim, vale observar se mudanças em atenção, clareza mental, irritabilidade ou sono surgem nas primeiras semanas após início, retomada ou uso irregular. O foco central costuma ser distinguir efeito percebido da medicação, flutuação da condição de base e impacto emocional de viver com queixas cognitivas persistentes.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe dias melhores ou piores de atenção, isso parece acompanhar mais o uso regular da medicação, a qualidade do sono ou o nível de estresse daquele dia? , Essa sensação de mente mais lenta ou mais confusa é constante ao longo da semana ou varia bastante conforme o horário, o contexto e o cansaço? , Quando você fica mais irritado ou inquieto, isso vem junto de sensação corporal de aceleração e dificuldade de parar, ou aparece mais em situações de frustração e cobrança? , Você notou alguma mudança clara depois que começou, retomou ou passou a falhar no uso, ou a impressão é de que as oscilações já aconteciam antes? , O que mais te incomoda hoje: não render como antes, esquecer coisas específicas, sentir-se mais cansado mentalmente ou o medo do que isso possa significar?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve piora cognitiva persistente ou confusão subjetiva nova após início
- retomada ou uso irregular
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar se há relação temporal relevante ou progressão da condição de base
- Quando a irritabilidade
- inquietação ou alteração importante de sono surge de modo mais marcado nas primeiras semanas e interfere no funcionamento
- pode valer comunicação para contextualizar a tolerabilidade percebida no cotidiano
- Quando o uso se mostra repetidamente irregular
- com abandono silencioso ou retomadas sem critério claro
- pode valer informar o médico assistente porque isso dificulta a leitura clínica da resposta e do próprio quadro
- Quando o paciente passa a relatar impacto funcional crescente de memória
- atenção ou organização
- sobretudo com repercussão ocupacional ou risco em atividades do dia a dia
- pode valer alinhamento para reavaliação do contexto clínico

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o sofrimento em torno de possível declínio cognitivo se intensifica e começa a organizar a vida psíquica em torno de medo
- evitação e desesperança
- a comunicação pode ajudar a integrar leitura neurológica e acompanhamento terapêutico

Vermelho: tratar como urgência

- Confusão acentuada de instalação recente
- desorientação
- fala muito desconexa ou rebaixamento importante do contato durante a sessão.: Interromper o trabalho interpretativo
- avaliar segurança imediata e acionar no mesmo dia médico assistente
- rede de apoio e emergência se necessário
- Ideação suicida emergente ou intensificada em contexto de desesperança marcada ligada a perda cognitiva
- funcionalidade ou medo de declínio.: Fazer manejo de risco na própria sessão e acionar hoje rede de apoio
- médico assistente e recursos de urgência conforme necessidade

Frase clínica

O foco costuma ser separar flutuação cognitiva, sofrimento com a condição de base e uso irregular de um efeito percebido da medicação.

139 ACETATO DE GLATIRÂMER

Substância: Acetato de Glatirâmer.

Nomes Comerciais: Copaxone, Glametix

Uso comum

- O acetato de glatirâmer é um imunomodulador usado sobretudo na esclerose múltipla remitente-recorrente. No consultório de terapia, ele tende a aparecer menos pelos efeitos subjetivos centrais do medicamento e mais pelo contexto de tratamento contínuo de uma doença neurológica imprevisível. Ao longo das primeiras semanas, o paciente pode estar mais atento a sensações corporais após a aplicação e à rotina de adesão; em seguimento prolongado, costumam ganhar peso clínico o cansaço do tratamento, a relação entre sintomas físicos e medo de progressão, e o impacto na identidade e na autonomia. O foco da sessão é discriminar sofrimento ligado à doença, à carga do tratamento e a eventos de vida, sem supor causalidade medicamentosa.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** A rotina de aplicações, o manejo de reações locais e a necessidade de constância podem ocupar espaço psíquico relevante, mesmo quando o paciente diz estar "acostumado". Em sessão, isso pode aparecer como irritação com a disciplina exigida, evitação do tema corporal ou sensação de viver em função do tratamento. Vale não confundir esse desgaste com desmotivação depressiva pura ou com "resistência" ao cuidado, sobretudo quando a adesão oscila em períodos de maior sobrecarga prática ou emocional.

Corpo e vigilância: Alguns pacientes passam a monitorar o corpo de modo mais intenso, tentando distinguir o que seria da doença, do tratamento ou de ansiedade antecipatória. Na sessão, podem surgir hipervigilância somática, medo de sinais físicos transitórios e dificuldade de confiar na própria leitura corporal. Isso pode se misturar tanto ao impacto real da esclerose múltipla quanto a experiências prévias de surtos, o que pede escuta discriminativa antes de atribuir o aumento de apreensão a piora psiquiátrica.

Identidade e autonomia: O tratamento contínuo pode reorganizar a forma como o paciente se percebe: alguém doente, alguém em risco, alguém dependente de rotina médica. Em sessão, isso às vezes aparece como luto pela espontaneidade perdida, vergonha do corpo marcado por aplicações ou tensão entre autonomia e necessidade de cuidado. Mudanças de humor e retraimento podem decorrer menos do medicamento em si e mais do efeito cumulativo de viver sob a possibilidade de limitação futura."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** A rotina de aplicações, o manejo de reações locais e a necessidade de constância podem ocupar espaço psíquico relevante, mesmo quando o paciente diz estar “acostumado”. Em sessão, isso pode aparecer como irritação com a disciplina exigida, evitação do tema corporal ou sensação de viver em função do tratamento. Vale não confundir esse desgaste com desmotivação depressiva pura ou com “resistência” ao cuidado, sobretudo quando a adesão oscila em períodos de maior sobrecarga prática ou emocional.

Corpo e vigilância: Alguns pacientes passam a monitorar o corpo de modo mais intenso, tentando distinguir o que seria da doença, do tratamento ou de ansiedade antecipatória. Na sessão, podem surgir hipervigilância somática, medo de sinais físicos transitórios e dificuldade de confiar na própria leitura corporal. Isso pode se misturar tanto ao impacto real da esclerose múltipla quanto a experiências prévias de surtos, o que pede escuta discriminativa antes de atribuir o aumento de apreensão a piora psiquiátrica.

Identidade e autonomia: O tratamento contínuo pode reorganizar a forma como o paciente se percebe: alguém doente, alguém em risco, alguém dependente de rotina médica. Em sessão, isso às vezes aparece como luto pela espontaneidade perdida, vergonha do corpo marcado por aplicações ou tensão entre autonomia e necessidade de cuidado. Mudanças de humor e retraimento podem decorrer menos do medicamento em si e mais do efeito cumulativo de viver sob a possibilidade de limitação futura.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O acetato de glatirâmer é um imunomodulador usado sobretudo na esclerose múltipla remitente-recorrente. No consultório de terapia, ele tende a aparecer menos pelos efeitos subjetivos centrais do medicamento e mais pelo contexto de tratamento contínuo de uma doença neurológica imprevisível. Ao longo das primeiras semanas, o paciente pode estar mais atento a sensações corporais após a aplicação e à rotina de adesão; em seguimento prolongado, costumam ganhar peso clínico o cansaço do tratamento, a relação entre sintomas físicos e medo de progressão, e o impacto na identidade e na autonomia. O foco da sessão é discriminar sofrimento ligado à doença, à carga do tratamento e a eventos de vida, sem supor causalidade medicamentosa.

Perguntas úteis

- "Quando você evita a aplicação ou adia o horário, isso costuma vir mais de esquecimento prático, cansaço da rotina ou de medo do que pode sentir no corpo depois? , O que mais pesa quando você percebe uma sensação física nova: a intensidade da sensação em si ou a ideia de que isso possa significar piora da doença? , Nos dias em que você se sente mais para baixo, isso vem junto de pensamentos sobre perda de autonomia e futuro, ou aparece mesmo quando a doença está menos em foco? , Quando você fala que está exausto do tratamento, essa exaustão parece mais corporal, emocional, ou ligada à obrigação de manter uma rotina que lembra a doença o tempo todo?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a falhar repetidamente nas aplicações
- esconder interrupções ou minimizar a própria irregularidade
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a adesão real e o impacto disso no seguimento
- Quando sensações físicas após a aplicação geram medo crescente
- evitação importante ou interpretações catastróficas persistentes
- pode valer comunicar o médico para esclarecer se há intercorrência clínica que esteja ampliando o sofrimento
- Quando há piora funcional relevante
- novos sintomas neurológicos referidos ou mudança importante no padrão corporal habitual
- pode valer contato com o médico assistente para não confundir sofrimento psíquico com possível atividade da doença
- Quando o tratamento passa a ocupar o centro da vida psíquica
- com retraimento
- desesperança ou abandono de atividades
- pode valer alinhar com o médico para integrar leitura clínica da carga do tratamento e da condição de base

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- aparecem falta de ar
- mal-estar intenso
- sensação de desmaio iminente ou piora física aguda em curso após aplicação recente.: Interromper o enquadre habitual
- acionar avaliação médica imediata e rede de apoio conforme necessidade
- O paciente descreve novos sintomas neurológicos importantes em curso
- como fraqueza acentuada
- alteração visual súbita ou dificuldade importante para andar.: Tratar como necessidade de avaliação médica no mesmo dia
- orientando busca imediata de atendimento e acionando suporte disponível
- A sessão revela ideação suicida com intenção
- plano ou perda importante de controle
- especialmente em contexto de desesperança ligada à doença e ao tratamento.: Realizar manejo de crise no próprio setting
- acionar rede de apoio e encaminhar para avaliação urgente no mesmo dia

Frase clínica

O foco clínico costuma estar menos no fármaco e mais em como o tratamento contínuo da esclerose múltipla reorganiza corpo, rotina e identidade.

140 ALENTUZUMABE

Substância: Alentuzumabe.

Nomes Comerciais: Lemtrada

Uso comum

- Alentuzumabe é um biológico de uso altamente especializado, encontrado sobretudo em pacientes com esclerose múltipla em acompanhamento prolongado. No consultório de terapia, o foco raramente é o fármaco em si, mas o impacto de um tratamento intenso e intermitente sobre rotina, identidade, autonomia e expectativa de futuro. Entre ciclos e monitoramentos que podem se estender por meses a anos, o paciente pode chegar mais mobilizado por incerteza, vigilância corporal e medo de novas intercorrências do que por mudanças subjetivas claramente atribuíveis à medicação. Vale acompanhar como a experiência de doença e tratamento reorganiza o trabalho terapêutico ao longo do tempo.

O paciente pode relatar

- "Carga do tratamento:** O tratamento pode ocupar espaço psíquico desproporcional na vida do paciente, mesmo fora dos períodos de infusão, por causa de exames frequentes, antecipação de intercorrências e necessidade de vigilância contínua. Em sessão, isso pode aparecer como agenda mental capturada pelo acompanhamento médico, oscilando entre hiperfoco corporal e tentativa de evitar o tema. Essa apresentação pode se confundir com ansiedade basal, traços obsessivos prévios ou reação compreensível a fases mais instáveis da doença, de modo que vale situar o quanto essa centralidade aumentou após o início do tratamento e como varia entre consultas e eventos clínicos.

Funcionalidade e identidade: Pacientes em uso de alentuzumabe costumam estar lidando não apenas com sintomas, mas com a experiência de viver sob a possibilidade de surtos, limitações e redefinições de autonomia. Na sessão, podem surgir luto pela linha de base anterior, vergonha por depender de ajuda, oscilação entre autossuficiência rígida e sensação de fragilidade. Isso pode ser lido apressadamente como depressão, desmotivação ou resistência terapêutica, quando às vezes reflete reorganização identitária diante de uma condição crônica e de um tratamento de alta complexidade.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, equipe de infusão e sistema de saúde frequentemente entra no campo transferencial como fonte de amparo, submissão, desconfiança ou exaustão. O paciente pode alternar gratidão intensa, irritação com monitoramentos e sensação de estar reduzido a exames e protocolos. Parte desse movimento decorre do próprio percurso de cuidado, mas também pode reencenar padrões relacionais prévios e influenciar adesão, comparecimento e comunicação de sintomas. Observar esse eixo ajuda a diferenciar conflito com a equipe de evitação mais ampla do adoecimento."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode ocupar espaço psíquico desproporcional na vida do paciente, mesmo fora dos períodos de infusão, por causa de exames frequentes, antecipação de intercorrências e necessidade de vigilância contínua. Em sessão, isso pode aparecer como agenda mental capturada pelo acompanhamento médico, oscilando entre hiperfoco corporal e tentativa de evitar o tema. Essa apresentação pode se confundir com ansiedade basal, traços obsessivos prévios ou reação compreensível a fases mais instáveis da doença, de modo que vale situar o quanto essa centralidade aumentou após o início do tratamento e como varia entre consultas e eventos clínicos.

Funcionalidade e identidade: Pacientes em uso de alentuzumabe costumam estar lidando não apenas com sintomas, mas com a experiência de viver sob a possibilidade de surtos, limitações e redefinições de autonomia. Na sessão, podem surgir luto pela linha de base anterior, vergonha por depender de ajuda, oscilação entre autossuficiência rígida e sensação de fragilidade. Isso pode ser lido apressadamente como depressão, desmotivação ou resistência terapêutica, quando às vezes reflete reorganização identitária diante de uma condição crônica e de um tratamento de alta complexidade.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, equipe de infusão e sistema de saúde frequentemente entra no campo transferencial como fonte de amparo, submissão, desconfiança ou exaustão. O paciente pode alternar gratidão intensa, irritação com monitoramentos e sensação de estar reduzido a exames e protocolos. Parte desse movimento decorre do próprio percurso de cuidado, mas também pode reencenar padrões relacionais prévios e influenciar adesão, comparecimento e comunicação de sintomas. Observar esse eixo ajuda a diferenciar conflito com a equipe de evitação mais ampla do adoecimento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Alentuzumabe é um biológico de uso altamente especializado, encontrado sobretudo em pacientes com esclerose múltipla em acompanhamento prolongado. No consultório de terapia, o foco raramente é o fármaco em si, mas o impacto de um tratamento intenso e intermitente sobre rotina, identidade, autonomia e expectativa de futuro. Entre ciclos e monitoramentos que podem se estender por meses a anos, o paciente pode chegar mais mobilizado por incerteza, vigilância corporal e medo de novas intercorrências do que por mudanças subjetivas claramente atribuíveis à medicação. Vale acompanhar como a experiência de doença e tratamento reorganiza o trabalho terapêutico ao longo do tempo.

Perguntas úteis

- "Quando você fala do tratamento, o que pesa mais hoje: medo do que pode acontecer, cansaço da rotina de acompanhamento ou sensação de perda de quem você era antes? , Nos períodos em que você evita pensar na doença, isso te traz alívio e mais vida fora do tema ou acaba atrasando conversas e cuidados que você sabe que seriam importantes? , Quando você se irrita com exames, retornos ou orientações da equipe, a sensação é de excesso de controle sobre você ou de não estar sendo suficientemente escutado? , A queda de ritmo que aparece em você tem mais cara de desânimo generalizado, de limitação física em dias específicos ou de esgotamento por viver em estado de alerta?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a omitir sintomas
- faltar a monitoramentos ou evitar retornos por saturação do tratamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar risco de ruptura no acompanhamento
- Quando surgem mudanças emocionais ou cognitivas novas e persistentes após um ciclo de tratamento
- sem explicação clara por eventos de vida
- pode valer comunicar o médico para contextualizar a evolução clínica
- Quando o medo de intercorrências domina a rotina a ponto de reduzir muito funcionalidade
- sono ou comparecimento a cuidados
- pode valer contato com a equipe assistente para coordenação mínima do manejo
- Quando o paciente relata conflito crescente com a equipe que esteja comprometendo confiança
- adesão ou comunicação de sinais físicos relevantes
- pode valer alinhar com o médico assistente para evitar desencontro de informações

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem confusão aguda
- desorientação
- rebaixamento importante do estado geral ou dificuldade súbita de sustentar a conversa em comparação com o padrão habitual.: Interromper a condução usual da sessão e acionar avaliação médica no mesmo dia
- com rede de apoio e emergência se necessário
- Surge ideação suicida com intenção
- plano ou sensação de perda de controle
- especialmente em contexto de piora clínica ou desesperança ligada à doença.: Fazer manejo de risco imediato
- acionar rede de apoio e avaliação urgente no mesmo dia
- incluindo contato com o médico assistente e emergência quando necessário

Frase clínica

Com alentuzumabe, o foco terapêutico costuma estar menos no fármaco e mais na carga psíquica de viver sob tratamento e monitoramento prolongados.

141 **BETAINTERFERONA 1B**

Substância: Betainterferona 1B.

Nomes Comerciais: Betaferon

Uso comum

- Betainterferona 1B é um biológico usado sobretudo na esclerose múltipla, contexto pouco frequente no consultório geral de psicoterapia. Para o terapeuta, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como um tratamento contínuo para doença crônica neurológica atravessa humor, rotina, identidade e vínculo com o cuidado. Nas primeiras semanas e nos primeiros meses, vale observar se surgem piora do humor, irritabilidade, retraimento ou maior exaustão, sem assumir causalidade direta. Ao longo do seguimento, o ponto central é discriminar entre impacto do tratamento, atividade da doença, perdas funcionais e sobrecarga emocional acumulada.

O paciente pode relatar

- **"Humor e retraimento:** Em parte dos pacientes, a sessão pode passar a ter mais desesperança, irritabilidade, choro fácil ou afastamento afetivo, às vezes em temporalidade próxima ao início do tratamento ou a fases de maior carga da doença. Isso pode se confundir com luto por perdas funcionais, progressão do quadro neurológico, dor, fadiga persistente ou eventos de vida que reduziram recursos psíquicos. Vale observar se a mudança representa rebaixamento global do humor ou se aparece mais como reação ao tratamento e ao significado de viver com uma condição crônica.

Fadiga e ritmo: Cansaço importante, lentificação, menor disponibilidade associativa e oscilação de presença na sessão podem ganhar destaque, inclusive quando o paciente mantém intenção de estar implicado no processo terapêutico. A leitura pode se embaralhar porque fadiga também acompanha a própria esclerose múltipla, alterações de sono, dor, infecções intercorrentes e outras medicações em uso. O ponto clínico é notar se há um padrão relativamente estável de exaustão ligada ao tratamento ou uma piora mais ampla da funcionalidade e do estado geral.

Carga do tratamento: Aplicações regulares, efeitos físicos percebidos, antecipação desconfortável do dia da medicação e sensação de viver em torno do tratamento podem ocupar espaço psíquico relevante. Na sessão, isso pode aparecer como irritação com a rotina, evitação de compromissos, sensação de aprisionamento ou adesão oscilante mantida em silêncio. Nem sempre se trata de resistência ao cuidado; às vezes o que pesa é a repetição do tratamento, o lembrete constante da doença e a dificuldade de sustentar autonomia sob monitoramento contínuo.

Identidade e funcionalidade: Mudanças no corpo, no ritmo e na previsibilidade da vida podem deslocar a autoimagem do paciente, com impacto em trabalho, sexualidade, projetos e posição familiar. O terapeuta pode notar maior sensibilidade a dependência, vergonha, comparação com o self prévio ou oscilação entre hiperadaptação e colapso. Isso pode ser atribuído apressadamente ao medicamento quando, na prática, muitas vezes reflete o encontro entre doença crônica, tratamento prolongado e perdas concretas de função.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, enfermagem e serviços de saúde pode aparecer marcada por confiança, submissão, ambivalência ou desgaste, especialmente quando o paciente sente que precisa suportar muito para seguir tratando. Na sessão, isso às vezes se traduz em silêncio sobre dificuldades, minimização de efeitos que ameaçam a adesão ou postura de resignação excessiva. Vale diferenciar uma aliança de cuidado consistente de uma adaptação defensiva em que o paciente deixa de nomear sofrimento relevante."

O que observar em sessão

- **Humor e retraimento:** Em parte dos pacientes, a sessão pode passar a ter mais desesperança, irritabilidade, choro fácil ou afastamento afetivo, às vezes em temporalidade próxima ao início do tratamento ou a fases de maior carga da doença. Isso pode se confundir com luto por perdas funcionais, progressão do quadro neurológico, dor, fadiga persistente ou eventos de vida que reduziram recursos psíquicos. Vale observar se a mudança representa rebaixamento global do humor ou se aparece mais como reação ao tratamento e ao significado de viver com uma condição crônica.

Fadiga e ritmo: Cansaço importante, lentificação, menor disponibilidade associativa e oscilação de presença na sessão podem ganhar destaque, inclusive quando o paciente mantém intenção de estar implicado no processo terapêutico. A leitura pode se embaralhar porque fadiga também acompanha a própria esclerose múltipla, alterações de sono, dor, infecções intercorrentes e outras medicações em uso. O ponto clínico é notar se há um padrão relativamente estável de exaustão ligada ao tratamento ou uma piora mais ampla da funcionalidade e do estado geral.

Carga do tratamento: Aplicações regulares, efeitos físicos percebidos, antecipação desconfortável do dia da medicação e sensação de viver em torno do tratamento podem ocupar espaço psíquico relevante. Na sessão, isso pode aparecer como irritação com a rotina, evitação de compromissos, sensação de aprisionamento ou adesão oscilante mantida em silêncio. Nem sempre se trata de resistência ao cuidado; às vezes o que pesa é a repetição do tratamento, o lembrete constante da doença e a dificuldade de sustentar autonomia sob monitoramento contínuo.

Identidade e funcionalidade: Mudanças no corpo, no ritmo e na previsibilidade da vida podem deslocar a autoimagem do paciente, com impacto em trabalho, sexualidade, projetos e posição familiar. O terapeuta pode notar maior sensibilidade a dependência, vergonha, comparação com o self prévio ou oscilação entre hiperadaptação e colapso. Isso pode ser atribuído apressadamente ao medicamento quando, na prática, muitas vezes reflete o encontro entre doença crônica, tratamento prolongado e perdas concretas de função.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, enfermagem e serviços de saúde pode aparecer marcada por confiança, submissão, ambivalência ou desgaste, especialmente quando o paciente sente que precisa suportar muito para seguir tratando. Na sessão, isso às vezes se traduz em silêncio sobre dificuldades, minimização de efeitos que ameaçam a adesão ou postura de resignação excessiva. Vale diferenciar uma aliança de cuidado consistente de uma adaptação defensiva em que o paciente deixa de nomear sofrimento relevante.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Betainterferona 1B é um biológico usado sobretudo na esclerose múltipla, contexto pouco frequente no consultório geral de psicoterapia. Para o terapeuta, o foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como um tratamento contínuo para doença crônica neurológica atravessa humor, rotina, identidade e vínculo com o cuidado. Nas primeiras semanas e nos primeiros meses, vale observar se surgem piora do humor, irritabilidade, retraimento ou maior exaustão, sem assumir causalidade direta. Ao longo do seguimento, o ponto central é discriminar entre impacto do tratamento, atividade da doença, perdas funcionais e sobrecarga emocional acumulada.

Perguntas úteis

- "Quando você se percebe mais para baixo ou mais irritado, isso parece espalhado pela semana inteira ou fica mais intenso em períodos próximos da aplicação? , Esse cansaço que aparece aqui na sessão se parece mais com sono e corpo pesado, com desânimo depressivo, ou com exaustão por lidar com a doença e a rotina de tratamento? , Quando você pensa em faltar, adiar ou evitar a medicação, o que pesa mais: desconforto físico, medo do que ela representa, sensação de inutilidade ou dificuldade prática de manter a rotina? , O afastamento que você descreve tem mais a ver com perda de interesse nas pessoas, vergonha de como está hoje, ou falta de energia para sustentar contato? , Nas últimas semanas, o que mudou primeiro: seu humor, sua disposição física, sua rotina de tratamento ou algum evento importante fora da doença?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a mostrar rebaixamento importante do humor
- retraimento persistente ou desesperança em temporalidade próxima ao início do tratamento ou a mudanças recentes no cuidado
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o quadro no conjunto clínico
- Quando a fadiga ou o mal-estar ficam tão intensos que o paciente começa a faltar à terapia
- reduzir atividades de base ou cogitar abandono silencioso do tratamento
- pode valer comunicação para avaliação do impacto funcional
- Quando surgem dificuldades relevantes de adesão mantidas em segredo
- especialmente por antecipação do desconforto das aplicações ou por desânimo crescente
- pode valer alinhar com a equipe para evitar ruptura do cuidado
- Quando o paciente descreve piora global do estado geral
- com queda acentuada de funcionalidade e mudança nítida do padrão habitual
- pode valer contato com o médico para diferenciar sobrecarga do tratamento
- intercorrência clínica e atividade da doença

Vermelho: tratar como urgência

- Ideias de morte
- autoagressão ou sensação de que não vale a pena seguir
- sobretudo se isso surge ou se intensifica nas primeiras semanas ou meses do tratamento.:
Fazer avaliação de risco na própria sessão e acionar no mesmo dia psiquiatra ou médico assistente
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Piora abrupta do estado geral durante a sessão
- com confusão incomum
- fraqueza acentuada ou incapacidade súbita de se manter funcional como de costume.:
Interromper o enquadre habitual
- avaliar necessidade de suporte imediato e acionar atendimento médico no mesmo dia

Frase clínica

O foco clínico é distinguir sofrimento ligado ao tratamento e à doença crônica de uma mudança afetiva que pede comunicação médica.

142 BETAINTERFERONA 1A

Substância: Betainterferona 1a.

Nomes Comerciais: Rebif, Bio-Manguinhos Betainterferona 1a, Avonex

Uso comum

- Betainterferona 1a é um imunomodulador usado sobretudo na esclerose múltipla remitente-recorrente. No consultório de terapia, ela aparece menos como foco principal do que como parte de um tratamento crônico que reorganiza rotina, identidade e expectativa de futuro. Nas primeiras semanas e nos dias de aplicação, alguns pacientes podem ficar mais cansados, lentificados ou irritáveis, o que pode confundir a leitura da sessão; ao longo de meses, o eixo central costuma ser a convivência com oscilações funcionais, medo de progressão e desgaste com tratamento contínuo. Vale acompanhar o que muda de forma previsível em torno das aplicações e o que persiste para além desse ritmo.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** A medicação pode entrar na sessão como mais uma exigência de uma vida já organizada em torno de sintomas, exames e incerteza clínica. Em alguns pacientes, os dias de aplicação ficam associados a indisposição, redução de energia ou necessidade de poupar atividades, o que pode ser vivido como perda de autonomia. Isso pode se confundir com desânimo depressivo, retraimento por frustração ou impacto cumulativo da própria esclerose múltipla, especialmente quando o paciente já vinha sobrecarregado antes do início do tratamento.

Humor e irritabilidade: Oscilações de humor, maior sensibilidade emocional ou irritabilidade podem aparecer no acompanhamento, às vezes de modo mais nítido no início do tratamento ou em torno dos dias de aplicação. Na sessão, o terapeuta pode notar menor tolerância à frustração, choro mais fácil ou sensação de estar “sem margem” para lidar com demandas habituais. A leitura exige cautela porque quadros depressivos associados à doença crônica, luto pela perda funcional, conflitos familiares e outras medicações também podem produzir apresentação semelhante.

Energia e lentificação: Cansaço, sensação de corpo pesado e menor disponibilidade cognitiva podem alterar o ritmo da sessão e a capacidade de elaboração, sobretudo quando coincidem com a rotina de aplicação. O paciente pode parecer menos espontâneo, mais concreto ou com dificuldade de sustentar associações, sem que isso signifique necessariamente piora global do quadro psíquico. Também aqui entram como confundidores o próprio curso da esclerose múltipla, distúrbios do sono, dor, sobrecarga ocupacional e humor deprimido.

Identidade e funcionalidade: Com frequência, o ponto clinicamente mais relevante não é um efeito isolado, mas o modo como o tratamento reforça a condição de “pessoa doente” e reorganiza projetos, trabalho e imagem de si. A sessão pode trazer vergonha de depender de rotina médica, medo de incapacidade futura ou esforço excessivo para parecer bem apesar de limitações. Isso pode ser confundido com resistência, evitação ou desinvestimento terapêutico, quando na verdade o paciente está tentando preservar continuidade narcísica em meio a uma doença crônica."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** A medicação pode entrar na sessão como mais uma exigência de uma vida já organizada em torno de sintomas, exames e incerteza clínica. Em alguns pacientes, os dias de aplicação ficam associados a indisposição, redução de energia ou necessidade de poupar atividades, o que pode ser vivido como perda de autonomia. Isso pode se confundir com desânimo depressivo, retraimento por frustração ou impacto cumulativo da própria esclerose múltipla, especialmente quando o paciente já vinha sobrecarregado antes do início do tratamento.

Humor e irritabilidade: Oscilações de humor, maior sensibilidade emocional ou irritabilidade podem aparecer no acompanhamento, às vezes de modo mais nítido no início do tratamento ou em torno dos dias de aplicação. Na sessão, o terapeuta pode notar menor tolerância à frustração, choro mais fácil ou sensação de estar “sem margem” para lidar com demandas habituais. A leitura exige cautela porque quadros depressivos associados à doença crônica, luto pela perda funcional, conflitos familiares e outras medicações também podem produzir apresentação semelhante.

Energia e lentificação: Cansaço, sensação de corpo pesado e menor disponibilidade cognitiva podem alterar o ritmo da sessão e a capacidade de elaboração, sobretudo quando coincidem com a rotina de aplicação. O paciente pode parecer menos espontâneo, mais concreto ou com dificuldade de sustentar associações, sem que isso signifique necessariamente piora global do quadro psíquico. Também aqui entram como confundidores o próprio curso da esclerose múltipla, distúrbios do sono, dor, sobrecarga ocupacional e humor deprimido.

Identidade e funcionalidade: Com frequência, o ponto clinicamente mais relevante não é um efeito isolado, mas o modo como o tratamento reforça a condição de “pessoa doente” e reorganiza projetos, trabalho e imagem de si. A sessão pode trazer vergonha de depender de rotina médica, medo de incapacidade futura ou esforço excessivo para parecer bem apesar de limitações. Isso pode ser confundido com resistência, evitação ou desinvestimento terapêutico, quando na verdade o paciente está tentando preservar continuidade narcísica em meio a uma doença crônica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Betainterferona 1a é um imunomodulador usado sobretudo na esclerose múltipla remitente-recorrente. No consultório de terapia, ela aparece menos como foco principal do que como parte de um tratamento crônico que reorganiza rotina, identidade e expectativa de futuro. Nas primeiras semanas e nos dias de aplicação, alguns pacientes podem ficar mais cansados, lentificados ou irritáveis, o que pode confundir a leitura da sessão; ao longo de meses, o eixo central costuma ser a convivência com oscilações funcionais, medo de progressão e desgaste com tratamento contínuo. Vale acompanhar o que muda de forma previsível em torno das aplicações e o que persiste para além desse ritmo.

Perguntas úteis

- "Você percebe que os dias mais difíceis seguem algum padrão em relação à aplicação, ou ficam espalhados pela semana sem um ritmo claro? , Quando seu humor piora, isso vem junto de cansaço e indisposição corporal, ou aparece mais ligado a pensamentos sobre futuro, perdas e limitações? , Nessas semanas em que você chega mais lentificado, você se sente sonolento e sem energia física, ou mais desanimado e sem vontade de se envolver com as coisas? , O quanto essa irritação parece surgir do seu estado físico naquele período, e o quanto ela se intensifica em situações relacionais específicas? , Quando você evita compromissos ou reduz atividades, isso costuma ser para se recuperar de um mal-estar previsível, ou por medo de não dar conta mesmo em dias melhores?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- encurtar sessões ou reduzir atividades de forma claramente associada ao tratamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o impacto funcional e o risco de abandono silencioso
- Quando surgem rebaixamento persistente do humor
- desesperança ou perda importante de interesse que ultrapassam o padrão dos dias de aplicação
- pode valer comunicar o médico para discriminar efeito do tratamento
- evolução do quadro psíquico e impacto da doença de base
- Quando o paciente descreve piora importante e contínua de energia
- cognição ou funcionalidade sem relação temporal clara com a rotina de aplicação
- pode valer contato com o médico para contextualizar a mudança clínica
- Quando há sofrimento acentuado com a condição crônica
- recusa crescente do tratamento ou ambivalência marcada em seguir o acompanhamento
- pode valer alinhar com o médico para favorecer leitura compartilhada da adesão

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecimento de ideação suicida
- sensação de não suportar continuar ou fala de desesperança intensa com perda de perspectiva de futuro.: Fazer avaliação de risco na sessão e acionar no mesmo dia psiquiatra
- rede de apoio e emergência quando necessário
- Confusão importante
- piora abrupta do estado mental ou incapacidade incomum de se orientar e sustentar a conversa em comparação com o baseline recente.: Interromper o manejo habitual da sessão e buscar avaliação médica no mesmo dia
- com apoio da rede se preciso

Frase clínica

O foco clínico costuma ser menos o fármaco em si e mais como o tratamento crônico reorganiza humor, energia, adesão e identidade.

143 CLADRIBINA

Substância: Cladribina.

Nomes Comerciais: Mavenclad, Leustatin

Uso comum

- Cladribina é um imunomodulador/imunossupressor usado em contextos especializados, sobretudo esclerose múltipla e algumas condições hematológicas, portanto tende a aparecer no consultório mais pelo impacto do tratamento e da doença de base do que por um perfil subjetivo específico do fármaco. Na terapia, costuma ser mais útil acompanhar o que muda ao longo das semanas e meses após ciclos de tratamento: oscilações de energia, interrupções da rotina por exames e seguimento médico, apreensão com infecções e incerteza sobre o curso da doença. O foco clínico é distinguir sofrimento ligado ao tratamento contínuo, à condição de base e a eventos de vida concorrentes, sem supor causalidade medicamentosa.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** O paciente pode chegar mais ocupado por agendas médicas, exames, afastamentos e necessidade de reorganizar trabalho, estudo ou cuidados domésticos. Em sessão, isso às vezes aparece como redução de disponibilidade psíquica para elaboração, maior concretude do discurso e sensação de vida suspensa. Vale não atribuir automaticamente esse estreitamento ao medicamento: a própria condição de base, o medo de piora e mudanças recentes na rotina podem explicar parte importante do que se observa.

Sofrimento associado à condição: Quando a cladribina aparece no tratamento, frequentemente a doença de base já ocupa lugar central na identidade e no horizonte do paciente. Podem emergir medo de progressão, hipervigilância corporal, luto pela perda de previsibilidade e oscilação entre esperança e desalento. Na leitura clínica, convém diferenciar o que acompanha o curso da condição, o impacto simbólico de estar em tratamento mais especializado e reações a eventos externos que coincidem com essa fase.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, hematologista ou outros membros da equipe pode influenciar fortemente a adesão ao seguimento e o tom emocional trazido à sessão. Alguns pacientes chegam mais confiantes quando se sentem amparados; outros mostram retraimento, irritação ou evitação quando vivem o acompanhamento como invasivo ou pouco compreensível. Se houver falhas em comparecimento, mensagens ambivalentes sobre continuidade ou silêncio sobre sintomas físicos, isso pode refletir tanto sobrecarga emocional quanto dificuldades práticas e não apenas resistência ao cuidado."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O paciente pode chegar mais ocupado por agendas médicas, exames, afastamentos e necessidade de reorganizar trabalho, estudo ou cuidados domésticos. Em sessão, isso às vezes aparece como redução de disponibilidade psíquica para elaboração, maior concretude do discurso e sensação de vida suspensa. Vale não atribuir automaticamente esse estreitamento ao medicamento: a própria condição de base, o medo de piora e mudanças recentes na rotina podem explicar parte importante do que se observa.

Sofrimento associado à condição: Quando a cladribina aparece no tratamento, frequentemente a doença de base já ocupa lugar central na identidade e no horizonte do paciente. Podem emergir medo de progressão, hipervigilância corporal, luto pela perda de previsibilidade e oscilação entre esperança e desalento. Na leitura clínica, convém diferenciar o que acompanha o curso da condição, o impacto simbólico de estar em tratamento mais especializado e reações a eventos externos que coincidem com essa fase.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, hematologista ou outros membros da equipe pode influenciar fortemente a adesão ao seguimento e o tom emocional trazido à sessão. Alguns pacientes chegam mais confiantes quando se sentem amparados; outros mostram retraimento, irritação ou evitação quando vivem o acompanhamento como invasivo ou pouco compreensível. Se houver falhas em comparecimento, mensagens ambivalentes sobre continuidade ou silêncio sobre sintomas físicos, isso pode refletir tanto sobrecarga emocional quanto dificuldades práticas e não apenas resistência ao cuidado.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Cladribina é um imunomodulador/imunossupressor usado em contextos especializados, sobretudo esclerose múltipla e algumas condições hematológicas, portanto tende a aparecer no consultório mais pelo impacto do tratamento e da doença de base do que por um perfil subjetivo específico do fármaco. Na terapia, costuma ser mais útil acompanhar o que muda ao longo das semanas e meses após ciclos de tratamento: oscilações de energia, interrupções da rotina por exames e seguimento médico, apreensão com infecções e incerteza sobre o curso da doença. O foco clínico é distinguir sofrimento ligado ao tratamento contínuo, à condição de base e a eventos de vida concorrentes, sem supor causalidade medicamentosa.

Perguntas úteis

- "Quando você pensa no que mais tem pesado desde o início desse tratamento, isso se parece mais com medo do que a doença pode trazer, com cansaço da rotina médica ou com algo que mudou no seu corpo no dia a dia? , Essas mudanças na sua disposição e presença na sessão começaram junto com alguma etapa do tratamento, com uma piora da condição de base ou com acontecimentos importantes fora da saúde? , Quando você evita pensar ou falar sobre o tratamento, isso vem mais de exaustão com o tema, de receio do que pode ouvir dos médicos ou de sensação de que sua vida ficou reduzida à doença? , Nos dias em que você se sente pior, o que costuma aparecer primeiro: sintomas físicos, preocupação com exames e consultas, ou conflitos e pressões da sua rotina?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar a consultas
- exames ou seguimento médico por evitação
- confusão ou sobrecarga
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar risco de descontinuidade do cuidado
- Quando surgem mudanças importantes de humor
- energia ou cognição temporalmente próximas ao tratamento e difíceis de explicar apenas por eventos de vida
- pode valer comunicar para contextualização clínica conjunta
- Quando o paciente relata infecções recorrentes
- febre
- prostração acentuada ou adoecimento físico que está interferindo claramente no processo terapêutico
- pode valer contato com a equipe assistente pela relevância clínica do quadro
- Quando a sessão revela desesperança crescente ligada à doença
- com retraimento importante e abandono silencioso do autocuidado
- pode valer alinhar com o médico para integrar leitura de risco e sustentação do seguimento

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente apresenta febre referida com piora importante do estado geral
- confusão
- fraqueza acentuada ou aspecto visivelmente adoecido.: Interromper o foco psicoterápico e encaminhar para avaliação médica no mesmo dia
- acionando rede de apoio e serviços de urgência quando necessário
- Surge ideação suicida com intenção
- plano ou sensação de que não vale mais sustentar o tratamento e a própria vida diante da doença.: Fazer manejo de risco imediatamente
- acionar rede de apoio e avaliação urgente
- com comunicação ao médico assistente conforme o contexto

Frase clínica

Com cladribina, o centro da escuta costuma ser menos o fármaco e mais o peso subjetivo do tratamento contínuo e da doença de base.

144 CLORIDRATO DE FINGOLIMODE

Substância: Cloridrato de Fingolimode.

Nomes Comerciais: Gilenya, Cloridrato de Fingolimode

Uso comum

- O cloridrato de fingolimode é um imunomodulador usado sobretudo na esclerose múltipla recorrente. No consultório de terapia, ele tende a aparecer menos pelos efeitos subjetivos diretos do medicamento e mais pelo contexto de tratamento contínuo de uma condição neurológica imprevisível, com impacto sobre rotina, autonomia e identidade. Nas primeiras semanas após início ou retomada, vale atenção a mudanças de disposição, cansaço, sensação de lentificação ou mal-estar que o paciente associe ao tratamento, sem presumir causalidade. Ao longo dos meses, o foco costuma ser menos “o remédio em si” e mais como o paciente sustenta adesão, lida com exames, medo de piora e oscilação funcional.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como peso prático e simbólico: consultas, exames, monitoramento e a lembrança recorrente de uma doença crônica. Alguns pacientes chegam mais tomados por fadiga, irritação ou sensação de vida organizada em torno da condição, o que pode parecer desmotivação inespecífica ou retraimento depressivo. Vale observar se a sobrecarga cresce em torno de etapas do acompanhamento médico, de intercorrências clínicas ou de períodos em que a adesão fica mais frágil.

Funcionalidade e identidade: Mudanças de energia, ritmo cognitivo e confiança corporal podem repercutir no trabalho terapêutico mais como ameaça à autonomia do que como sintoma psiquiátrico primário. Na sessão, isso pode aparecer em luto pela versão anterior de si, hipervigilância a sinais do corpo ou oscilação entre negação e preocupação excessiva. A leitura pode se confundir com episódio depressivo, ansiedade de desempenho ou efeito atribuído ao medicamento, quando às vezes o centro é a experiência de viver com uma condição potencialmente incapacitante.

Humor e ansiedade: Humor mais rebaixado, apreensão com o futuro e irritabilidade podem surgir no curso do tratamento, mas nem sempre se separam com clareza entre efeito percebido do medicamento, reação à doença, eventos de vida e exaustão acumulada. O terapeuta pode notar menor acesso afetivo, fala mais pessimista ou aumento de ruminação sobre perda de controle. A discriminação clínica costuma depender de situar temporalmente essas mudanças em relação ao início ou retomada do uso, a notícias médicas recentes e ao padrão prévio do paciente."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como peso prático e simbólico: consultas, exames, monitoramento e a lembrança recorrente de uma doença crônica. Alguns pacientes chegam mais tomados por fadiga, irritação ou sensação de vida organizada em torno da condição, o que pode parecer desmotivação inespecífica ou retraimento depressivo. Vale observar se a sobrecarga cresce em torno de etapas do acompanhamento médico, de intercorrências clínicas ou de períodos em que a adesão fica mais frágil.

Funcionalidade e identidade: Mudanças de energia, ritmo cognitivo e confiança corporal podem repercutir no trabalho terapêutico mais como ameaça à autonomia do que como sintoma psiquiátrico primário. Na sessão, isso pode aparecer em luto pela versão anterior de si, hipervigilância a sinais do corpo ou oscilação entre negação e preocupação excessiva. A leitura pode se confundir com episódio depressivo, ansiedade de desempenho ou efeito atribuído ao medicamento, quando às vezes o centro é a experiência de viver com uma condição potencialmente incapacitante.

Humor e ansiedade: Humor mais rebaixado, apreensão com o futuro e irritabilidade podem surgir no curso do tratamento, mas nem sempre se separam com clareza entre efeito percebido do medicamento, reação à doença, eventos de vida e exaustão acumulada. O terapeuta pode notar menor acesso afetivo, fala mais pessimista ou aumento de ruminação sobre perda de controle. A discriminação clínica costuma depender de situar temporalmente essas mudanças em relação ao início ou retomada do uso, a notícias médicas recentes e ao padrão prévio do paciente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O cloridrato de fingolimode é um imunomodulador usado sobretudo na esclerose múltipla recorrente. No consultório de terapia, ele tende a aparecer menos pelos efeitos subjetivos diretos do medicamento e mais pelo contexto de tratamento contínuo de uma condição neurológica imprevisível, com impacto sobre rotina, autonomia e identidade. Nas primeiras semanas após início ou retomada, vale atenção a mudanças de disposição, cansaço, sensação de lentificação ou mal-estar que o paciente associe ao tratamento, sem presumir causalidade. Ao longo dos meses, o foco costuma ser menos “o remédio em si” e mais como o paciente sustenta adesão, lida com exames, medo de piora e oscilação funcional.

Perguntas úteis

- "Essas mudanças de humor ou energia começaram mais perto do início ou da retomada do tratamento, ou vieram se construindo junto com preocupações sobre a doença e a rotina? , Quando você se sente pior, isso aparece como tristeza e desesperança mais contínuas, ou como medo ligado a exames, sintomas físicos e possibilidade de piora? , Nos dias em que você evita atividades, o que pesa mais: cansaço corporal, sensação de lentidão para pensar, desânimo emocional ou receio de que algo aconteça com seu corpo? , Você percebe que sua relação com o tratamento fica mais difícil em momentos de efeitos incômodos, de descrença no benefício ou de cansaço de viver em função da doença?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente associa o início ou a retomada do fingolimode a piora nítida e persistente de humor
- ansiedade ou funcionamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar temporalmente o quadro e revisar hipóteses clínicas
- Quando surgem sinais de adesão irregular
- interrupções por conta própria ou ambivalência importante em seguir o tratamento
- pode valer comunicar o médico para reduzir risco clínico e esclarecer o contexto da irregularidade
- Quando a sessão passa a ser dominada por fadiga
- lentificação
- mal-estar ou queda funcional que o paciente relaciona ao tratamento
- pode valer contato com o médico para diferenciar efeito percebido
- progressão da condição de base e outras intercorrências
- Quando aparecem sintomas depressivos mais intensos
- desesperança crescente ou retraimento importante em paciente já sobrecarregado pela doença
- pode valer alinhar com o médico para avaliação conjunta do momento clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- surgem ideação suicida com intenção
- planejamento ou sensação de perda de controle
- especialmente em contexto de piora recente do humor.: Fazer manejo imediato de risco
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- com encaminhamento para emergência quando necessário
- O paciente aparece confuso
- muito rebaixado fisicamente ou relata mal-estar intenso acompanhado de sensação de descompensação clínica aguda.: Interromper a exploração psicoterápica
- priorizar avaliação médica imediata e acionar suporte de urgência conforme o contexto

Frase clínica

Com fingolimode, o foco terapêutico costuma estar menos no fármaco e mais na carga subjetiva de viver e tratar uma condição neurológica crônica.

145 FUMARATO DE DIMETILA

Substância: Fumarato de Dimetila.

Nomes Comerciais: Fumarato de Dimetila, Dyfucert, Tecfidera

Uso comum

- Fumarato de dimetila é um imunomodulador usado sobretudo na esclerose múltipla remitente-recorrente. No consultório de terapia, ele tende a aparecer menos pelo efeito subjetivo direto do medicamento e mais pelo contexto de uma doença crônica com curso imprevisível, exames de seguimento e oscilação funcional. Nas primeiras semanas, desconfortos físicos e adaptação à rotina de uso podem competir com a disponibilidade psíquica; ao longo dos meses, costuma ganhar peso a leitura que o paciente faz de fadiga, lapsos cognitivos, medo de progressão e impacto na identidade. O ponto central de observação é diferenciar sofrimento ligado ao tratamento e à condição de base de mudanças emocionais atribuídas de modo apressado ao remédio.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como rotina médica contínua, necessidade de exames, preocupação com resultados e sensação de viver sob monitoramento. Alguns pacientes chegam mais tomados por logística, antecipação e cansaço de sustentar cuidados do que por sintomas emocionais nomeados. Isso pode ser confundido com evitamento, desinvestimento terapêutico ou resistência, quando às vezes reflete sobrecarga concreta e reorganização da vida em torno da doença.

Funcionalidade e fadiga: Oscilações de energia, redução de ritmo e dificuldade de manter atividades podem aparecer como tema central, com impacto em trabalho, vida doméstica e participação social. Na sessão, vale notar se há lentificação, menor tolerância ao esforço de elaboração ou necessidade de pausas, sem concluir de imediato que se trata de humor deprimido. Fadiga da condição de base, pior qualidade de sono, estresse acumulado e outras medicações podem produzir um quadro subjetivamente parecido.

Cognição e autoconfiança: Lapsos de atenção, dificuldade para encontrar palavras ou sensação de estar menos afiado podem ganhar valor emocional desproporcional, sobretudo em pacientes que associam desempenho cognitivo à própria identidade. O terapeuta pode observar hesitação, maior necessidade de retomar o fio da conversa ou insegurança ao narrar eventos, mas isso não distingue sozinho efeito medicamentoso, ansiedade de desempenho ou flutuação da esclerose múltipla. O risco clínico aqui é o paciente passar a ler qualquer falha cotidiana como prova de piora irreversível.

Identidade e futuro: Com frequência, o sofrimento em sessão se organiza menos em torno do remédio e mais em torno do que significa viver com uma condição potencialmente recorrente. Medo de progressão, luto pela imagem corporal e pela autonomia, e revisão de projetos podem aparecer de forma intermitente, às vezes mascarados por um discurso excessivamente pragmático. Eventos de vida, experiências prévias com adoecimento e o modo como a equipe comunica o acompanhamento influenciam fortemente essa vivência."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como rotina médica contínua, necessidade de exames, preocupação com resultados e sensação de viver sob monitoramento. Alguns pacientes chegam mais tomados por logística, antecipação e cansaço de sustentar cuidados do que por sintomas emocionais nomeados. Isso pode ser confundido com evitamento, desinvestimento terapêutico ou resistência, quando às vezes reflete sobrecarga concreta e reorganização da vida em torno da doença.

Funcionalidade e fadiga: Oscilações de energia, redução de ritmo e dificuldade de manter atividades podem aparecer como tema central, com impacto em trabalho, vida doméstica e participação social. Na sessão, vale notar se há lentificação, menor tolerância ao esforço de elaboração ou necessidade de pausas, sem concluir de imediato que se trata de humor deprimido. Fadiga da condição de base, pior qualidade de sono, estresse acumulado e outras medicações podem produzir um quadro subjetivamente parecido.

Cognição e autoconfiança: Lapsos de atenção, dificuldade para encontrar palavras ou sensação de estar menos afiado podem ganhar valor emocional desproporcional, sobretudo em pacientes que associam desempenho cognitivo à própria identidade. O terapeuta pode observar hesitação, maior necessidade de retomar o fio da conversa ou insegurança ao narrar eventos, mas isso não distingue sozinho efeito medicamentoso, ansiedade de desempenho ou flutuação da esclerose múltipla. O risco clínico aqui é o paciente passar a ler qualquer falha cotidiana como prova de piora irreversível.

Identidade e futuro: Com frequência, o sofrimento em sessão se organiza menos em torno do remédio e mais em torno do que significa viver com uma condição potencialmente recorrente. Medo de progressão, luto pela imagem corporal e pela autonomia, e revisão de projetos podem aparecer de forma intermitente, às vezes mascarados por um discurso excessivamente pragmático. Eventos de vida, experiências prévias com adoecimento e o modo como a equipe comunica o acompanhamento influenciam fortemente essa vivência.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Fumarato de dimetila é um imunomodulador usado sobretudo na esclerose múltipla remitente-recorrente. No consultório de terapia, ele tende a aparecer menos pelo efeito subjetivo direto do medicamento e mais pelo contexto de uma doença crônica com curso imprevisível, exames de seguimento e oscilação funcional. Nas primeiras semanas, desconfortos físicos e adaptação à rotina de uso podem competir com a disponibilidade psíquica; ao longo dos meses, costuma ganhar peso a leitura que o paciente faz de fadiga, lapsos cognitivos, medo de progressão e impacto na identidade. O ponto central de observação é diferenciar sofrimento ligado ao tratamento e à condição de base de mudanças emocionais atribuídas de modo apressado ao remédio.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais esgotado, isso vem como cansaço físico, como desânimo emocional ou como uma sensação de travamento mental? , Esses lapsos de atenção ou memória aparecem de modo espalhado ao longo do dia ou ficam mais fortes em situações de estresse, cobrança ou medo de errar? , Quando você pensa no tratamento, o que pesa mais hoje: os sintomas do corpo, a rotina de acompanhamento ou o que isso significa para a sua vida daqui para frente? , Nas semanas em que você se sente pior, você percebe alguma mudança concreta na sua funcionalidade ou o sofrimento aumenta mais pela interpretação do que isso pode significar? , Você tem evitado atividades, encontros ou planos porque seu corpo não acompanha, porque teme passar mal, ou porque não quer se ver na posição de alguém em tratamento?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- reduzir engajamento ou mencionar uso irregular em meio a cansaço com o tratamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar barreiras de adesão que estejam ficando silenciosas
- Quando surgem piora funcional sustentada
- fadiga muito acima da linha de base ou queixas cognitivas que começam a interferir claramente no cotidiano
- pode valer comunicar o médico para ajudar na discriminação entre curso da condição
- intercorrência clínica e impacto do tratamento
- Quando o paciente atribui qualquer oscilação emocional ou corporal ao medicamento e isso começa a alimentar abandono silencioso ou desesperança
- pode valer contato com o médico para coordenar leitura clínica e reduzir interpretações precipitadas
- Quando aparecem desconfortos físicos persistentes que ocupam a sessão e diminuem a disponibilidade para o trabalho terapêutico
- pode valer alinhar com o médico assistente para que o manejo clínico global não fique fragmentado

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente parece agudamente confuso
- muito desorganizado
- ou relata mal-estar importante acompanhado de fraqueza intensa e incapacidade súbita de seguir a conversa.: Interromper o enquadre usual
- avaliar necessidade de apoio imediato e acionar médico
- rede de apoio ou emergência conforme gravidade e contexto

Vermelho: tratar como urgência

- Emergência de ideação suicida com intenção
- plano ou perda de controle
- especialmente se associada a sensação de futuro interrompido pela doença.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e encaminhar para avaliação urgente conforme o contexto clínico

Frase clínica

O foco costuma ser menos o fármaco em si e mais como tratamento, fadiga e incerteza da doença reorganizam identidade, funcionalidade e vínculo terapêutico.

146 NATALIZUMABE

Substância: Natalizumabe.

Nomes Comerciais: Tysabri

Uso comum

- Natalizumabe é um biológico usado sobretudo em esclerose múltipla e, em alguns contextos, em doença inflamatória intestinal. No consultório de terapia, tende a aparecer menos pelos efeitos subjetivos diretos do medicamento e mais pelo impacto de um tratamento contínuo para condição crônica, com infusões periódicas, monitoramento médico e incerteza sobre evolução clínica. Vale acompanhar como o paciente chega nas semanas próximas às aplicações e ao longo dos meses: ansiedade antecipatória, fadiga, oscilação de rotina, medo de piora e mudanças na identidade funcional podem pesar mais na sessão do que um efeito medicamentoso específico.

O paciente pode relatar

- "Carga do tratamento:** O tratamento pode ocupar espaço psíquico importante pela logística de infusões, exames, deslocamentos e necessidade de manter acompanhamento regular. Em sessão, isso às vezes aparece como cansaço com a rotina médica, sensação de vida organizada em torno do tratamento ou irritação com interrupções na agenda e no trabalho. Pode ser confundido com desmotivação depressiva ou evitamento, quando na verdade há sobrecarga concreta e desgaste acumulado com a condição de base.

Ansiedade e vigilância corporal: Alguns pacientes passam a monitorar intensamente sensações físicas, temendo sinais de piora neurológica ou complicações do tratamento. O terapeuta pode notar hipervigilância, dificuldade de simbolizar a experiência e tendência a ler qualquer oscilação corporal como ameaça iminente. Isso pode se misturar com ansiedade prévia, experiências anteriores de surtos, informações recebidas em consultas ou períodos de maior instabilidade clínica, exigindo cuidado para não reduzir tudo a ansiedade inespecífica.

Funcionalidade e identidade: Mudanças na disposição, na autonomia e na previsibilidade do corpo podem repercutir em autoestima, papéis familiares e imagem de futuro. Na sessão, pode surgir luto pela linha de base anterior, vergonha por depender de ajuda ou esforço para sustentar uma aparência de normalidade apesar de limitações variáveis. Parte desse material pode decorrer mais da evolução da doença e de eventos de vida associados do que do medicamento em si, e a distinção costuma aparecer quando se explora o que mudou no cotidiano concreto."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode ocupar espaço psíquico importante pela logística de infusões, exames, deslocamentos e necessidade de manter acompanhamento regular. Em sessão, isso às vezes aparece como cansaço com a rotina médica, sensação de vida organizada em torno do tratamento ou irritação com interrupções na agenda e no trabalho. Pode ser confundido com desmotivação depressiva ou evitamento, quando na verdade há sobrecarga concreta e desgaste acumulado com a condição de base.

Ansiedade e vigilância corporal: Alguns pacientes passam a monitorar intensamente sensações físicas, temendo sinais de piora neurológica ou complicações do tratamento. O terapeuta pode notar hipervigilância, dificuldade de simbolizar a experiência e tendência a ler qualquer oscilação corporal como ameaça iminente. Isso pode se misturar com ansiedade prévia, experiências anteriores de surtos, informações recebidas em consultas ou períodos de maior instabilidade clínica, exigindo cuidado para não reduzir tudo a ansiedade inespecífica.

Funcionalidade e identidade: Mudanças na disposição, na autonomia e na previsibilidade do corpo podem repercutir em autoestima, papéis familiares e imagem de futuro. Na sessão, pode surgir luto pela linha de base anterior, vergonha por depender de ajuda ou esforço para sustentar uma aparência de normalidade apesar de limitações variáveis. Parte desse material pode decorrer mais da evolução da doença e de eventos de vida associados do que do medicamento em si, e a distinção costuma aparecer quando se explora o que mudou no cotidiano concreto.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Natalizumabe é um biológico usado sobretudo em esclerose múltipla e, em alguns contextos, em doença inflamatória intestinal. No consultório de terapia, tende a aparecer menos pelos efeitos subjetivos diretos do medicamento e mais pelo impacto de um tratamento contínuo para condição crônica, com infusões periódicas, monitoramento médico e incerteza sobre evolução clínica. Vale acompanhar como o paciente chega nas semanas próximas às aplicações e ao longo dos meses: ansiedade antecipatória, fadiga, oscilação de rotina, medo de piora e mudanças na identidade funcional podem pesar mais na sessão do que um efeito medicamentoso específico.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe piora no humor ou na ansiedade, isso costuma vir mais ligado aos dias de tratamento, a sintomas do corpo ou a situações da sua vida fora do contexto médico? , O que mais pesa para você hoje: o efeito prático da doença na rotina, o medo do que pode acontecer adiante ou o cansaço de estar sempre em acompanhamento? , Quando você se sente mais travado ou desanimado, isso parece vir de falta de energia, de frustração com limites do corpo ou de vontade de se afastar das pessoas? , Nas semanas em que há consulta, exame ou infusão, você nota que fica mais vigilante com o corpo ou mais tomado por pensamentos de piora do que em outros períodos? , O quanto suas mudanças recentes afetaram o que você consegue fazer no dia a dia, em comparação com o quanto afetaram sua confiança em si mesmo?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve sintomas neurológicos novos
- claramente diferentes do seu padrão habitual
- pode valer alinhar com o médico assistente para checar se há mudança clínica da condição de base ou intercorrência relevante
- Quando a ansiedade em torno do tratamento leva a faltas
- adiamentos repetidos ou evitação de infusões e exames
- pode valer comunicar o médico para situar risco de adesão irregular
- Quando há rebaixamento importante do humor
- retraimento acentuado ou desesperança persistente em torno da doença e do tratamento
- pode valer alinhar com a equipe médica para integrar leitura clínica e momento do tratamento
- Quando o paciente chega à sessão confuso
- com lentificação incomum ou referindo mudança cognitiva percebida como abrupta por ele ou por familiares
- pode valer contato mais rápido com o médico assistente pela necessidade de avaliação clínica

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecimento em sessão de confusão
- desorientação
- dificuldade incomum para encontrar palavras ou mudança cognitiva abrupta percebida como fora do padrão do paciente.: Interromper a condução usual da sessão e acionar avaliação médica no mesmo dia
- envolvendo rede de apoio e emergência se necessário
- Ideação suicida com intenção
- plano ou sensação de que não conseguirá se manter seguro diante da sobrecarga da doença e do tratamento.: Manejar como urgência clínica hoje
- com acionamento de rede de apoio
- médico assistente e serviços de emergência quando necessário

Frase clínica

Com natalizumabe, o foco costuma ser menos o fármaco e mais o peso psíquico de viver em tratamento contínuo para uma condição crônica.

147 OCRELIZUMABE

Substância: Ocrelizumabe.

Nomes Comerciais: Ocrevus

Uso comum

- Ocrelizumabe é um biológico usado sobretudo na esclerose múltipla, um contexto pouco frequente no consultório de terapia em que o foco costuma recair menos sobre efeitos subjetivos específicos do fármaco e mais sobre a experiência de viver com uma condição neurológica crônica em tratamento contínuo. Na prática clínica, vale acompanhar o que muda nas semanas após infusões, quando podem surgir cansaço, mal-estar ou maior apreensão com o corpo, e observar ao longo dos meses como o paciente organiza rotina, trabalho, autonomia e expectativas em torno da doença. O ponto central na sessão é diferenciar impacto do tratamento, flutuação da condição de base e sofrimento psíquico reativo ao curso da doença.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como agenda de infusões, exames, deslocamentos, necessidade de planejamento e sensação de vida organizada em torno do cuidado médico. Em alguns pacientes, isso aparece como cansaço, irritabilidade, menor disponibilidade psíquica ou redução do espaço mental para elaboração de outros temas. Convém não atribuir automaticamente esse estreitamento ao medicamento: a própria doença, intercorrências clínicas e o acúmulo de demandas práticas podem explicar boa parte da mudança no padrão da sessão.

Funcionalidade e identidade: Mudanças em energia, ritmo, autonomia e confiança no próprio corpo podem repercutir em trabalho, estudo, sexualidade, vida social e autoimagem. Na sessão, o paciente pode oscilar entre esforço de normalização e vivência de perda, às vezes minimizando limitações em um momento e, em outro, organizando a identidade quase inteiramente em torno do adoecimento. Vale discriminar o que acompanha flutuações neurológicas e o que se relaciona a luto, vergonha, medo de dependência ou retração progressiva.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, serviço de infusão e exames pode aparecer marcada por confiança, dependência, ambivalência ou exaustão. Alguns pacientes chegam mais contidos, como se a linguagem médica ocupasse o campo da experiência, enquanto outros trazem frustração com incerteza, espera e necessidade de monitoramento contínuo. O terapeuta ganha mais quando observa como o paciente se posiciona diante do cuidado e da própria vulnerabilidade do que quando tenta inferir significado técnico de cada intercorrência."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como agenda de infusões, exames, deslocamentos, necessidade de planejamento e sensação de vida organizada em torno do cuidado médico. Em alguns pacientes, isso aparece como cansaço, irritabilidade, menor disponibilidade psíquica ou redução do espaço mental para elaboração de outros temas. Convém não atribuir automaticamente esse estreitamento ao medicamento: a própria doença, intercorrências clínicas e o acúmulo de demandas práticas podem explicar boa parte da mudança no padrão da sessão.

Funcionalidade e identidade: Mudanças em energia, ritmo, autonomia e confiança no próprio corpo podem repercutir em trabalho, estudo, sexualidade, vida social e autoimagem. Na sessão, o paciente pode oscilar entre esforço de normalização e vivência de perda, às vezes minimizando limitações em um momento e, em outro, organizando a identidade quase inteiramente em torno do adoecimento. Vale discriminar o que acompanha flutuações neurológicas e o que se relaciona a luto, vergonha, medo de dependência ou retração progressiva.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, serviço de infusão e exames pode aparecer marcada por confiança, dependência, ambivalência ou exaustão. Alguns pacientes chegam mais contidos, como se a linguagem médica ocupasse o campo da experiência, enquanto outros trazem frustração com incerteza, espera e necessidade de monitoramento contínuo. O terapeuta ganha mais quando observa como o paciente se posiciona diante do cuidado e da própria vulnerabilidade do que quando tenta inferir significado técnico de cada intercorrência.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Ocrelizumabe é um biológico usado sobretudo na esclerose múltipla, um contexto pouco frequente no consultório de terapia em que o foco costuma recair menos sobre efeitos subjetivos específicos do fármaco e mais sobre a experiência de viver com uma condição neurológica crônica em tratamento contínuo. Na prática clínica, vale acompanhar o que muda nas semanas após infusões, quando podem surgir cansaço, mal-estar ou maior apreensão com o corpo, e observar ao longo dos meses como o paciente organiza rotina, trabalho, autonomia e expectativas em torno da doença. O ponto central na sessão é diferenciar impacto do tratamento, flutuação da condição de base e sofrimento psíquico reativo ao curso da doença.

Perguntas úteis

- "Quando você se percebe mais limitado ou cansado, isso costuma aparecer em torno das infusões e exames ou vem de um jeito mais espalhado no seu dia a dia? , Nas semanas em que o tratamento ocupa mais espaço, você sente principalmente medo do que pode acontecer com o corpo, frustração por depender de cuidados ou um desânimo mais amplo que já toma outras áreas da vida? , Quando você evita planos, encontros ou trabalho, isso parece mais uma tentativa de poupar energia física, de não se expor a possíveis falhas do corpo ou de se afastar porque nada tem feito muito sentido? , O que muda na sua forma de estar aqui na sessão quando você sai de consultas ou recebe resultados: você fica mais aliviado, mais vigilante com sinais do corpo ou mais sem acesso ao que sente?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve piora funcional nítida
- nova limitação corporal ou mudança neurológica percebida nas últimas horas ou dias
- pode valer alinhar com o médico assistente para checar se há intercorrência clínica da condição de base
- Quando o tratamento passa a ser evitado
- adiado ou vivido com forte ambivalência não verbalizada à equipe
- pode valer comunicação para reduzir risco de abandono silencioso do acompanhamento
- Quando surgem febre
- mal-estar importante ou sensação de adoecimento associada a rebaixamento acentuado do funcionamento
- pode valer contato com o médico para avaliação clínica oportuna
- Quando a sessão passa a ser dominada por medo persistente de piora física após infusões ou exames
- com impacto relevante na adesão e na rotina
- pode ser útil alinhar com a equipe para contextualizar o momento do tratamento

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão surge piora neurológica aguda percebida pelo paciente
- como fraqueza nova
- alteração importante da fala
- da visão ou da marcha.: Interromper o foco psicoterápico e acionar avaliação médica no mesmo dia
- recorrendo à emergência se a alteração estiver em curso ou for intensa
- O paciente chega muito confuso
- desorganizado
- sonolento de modo incomum ou com rebaixamento importante do estado geral.: Priorizar segurança imediata
- acionar rede de apoio e avaliação médica urgente no mesmo dia

Frase clínica

Com ocrelizumabe, o foco da terapia costuma ser menos o fármaco e mais o impacto de viver e se organizar em torno de uma doença neurológica crônica.

148 OFATUMUMABE

Substância: Ofatumumabe.

Nomes Comerciais: Kesimpta

Uso comum

- Ofatumumabe é um biológico usado em tratamento contínuo, mais frequentemente em esclerose múltipla, e tende a chegar ao consultório menos pelos efeitos subjetivos diretos do medicamento do que pela experiência de viver com uma doença crônica e com um regime regular de aplicação e monitoramento. Nas primeiras semanas, podem ganhar relevo apreensão com o início, vigilância corporal aumentada e reorganização da rotina; ao longo dos meses, costumam pesar mais a oscilação entre estabilidade e medo de piora, a fadiga atribuída de modos diferentes e o impacto na identidade. O ponto central na sessão é discriminar sofrimento ligado ao tratamento, à condição de base e a eventos de vida, sem supor causalidade.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** O tratamento pode aparecer como presença constante na organização da semana, na antecipação de aplicações, em checagens corporais e em decisões práticas sobre trabalho, deslocamentos e vida social. Em sessão, isso às vezes se mostra como agenda mais rígida, maior necessidade de controle ou irritação com imprevistos. Vale não ler automaticamente esse estreitamento como traço de personalidade ou piora ansiosa primária, porque parte dele pode acompanhar a adaptação a um tratamento contínuo; por outro lado, eventos de vida e experiências prévias com adoecimento também podem ampliar essa carga.

Sofrimento e incerteza: Mesmo quando o quadro neurológico parece estável, pode haver medo persistente de progressão, hipervigilância a sensações corporais e dificuldade de confiar em períodos de melhora. O terapeuta pode notar oscilação entre alívio e catastrofização, com pouca capacidade de usar a estabilidade como experiência emocionalmente assimilável. Isso pode se confundir com ansiedade basal, com lembranças de fases anteriores da doença ou com notícias e relatos de terceiros que reativam ameaça, mais do que com efeito direto do medicamento.

Funcionalidade e identidade: Mudanças na forma como o paciente se percebe podem ganhar o centro da sessão: sensação de fragilidade, identidade organizada em torno do diagnóstico ou esforço excessivo para provar normalidade. Às vezes a funcionalidade real está preservada, mas a autoimagem permanece empobrecida; em outros casos, pequenas perdas objetivas são minimizadas e só aparecem indiretamente no vínculo e na frustração. Convém diferenciar o impacto subjetivo da condição de base, a adaptação ao tratamento e efeitos de contexto, como afastamentos, dependência prática de terceiros ou mudanças no papel familiar."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode aparecer como presença constante na organização da semana, na antecipação de aplicações, em checagens corporais e em decisões práticas sobre trabalho, deslocamentos e vida social. Em sessão, isso às vezes se mostra como agenda mais rígida, maior necessidade de controle ou irritação com imprevistos. Vale não ler automaticamente esse estreitamento como traço de personalidade ou piora ansiosa primária, porque parte dele pode acompanhar a adaptação a um tratamento contínuo; por outro lado, eventos de vida e experiências prévias com adoecimento também podem ampliar essa carga.

Sofrimento e incerteza: Mesmo quando o quadro neurológico parece estável, pode haver medo persistente de progressão, hipervigilância a sensações corporais e dificuldade de confiar em períodos de melhora. O terapeuta pode notar oscilação entre alívio e catastrofização, com pouca capacidade de usar a estabilidade como experiência emocionalmente assimilável. Isso pode se confundir com ansiedade basal, com lembranças de fases anteriores da doença ou com notícias e relatos de terceiros que reativam ameaça, mais do que com efeito direto do medicamento.

Funcionalidade e identidade: Mudanças na forma como o paciente se percebe podem ganhar o centro da sessão: sensação de fragilidade, identidade organizada em torno do diagnóstico ou esforço excessivo para provar normalidade. Às vezes a funcionalidade real está preservada, mas a autoimagem permanece empobrecida; em outros casos, pequenas perdas objetivas são minimizadas e só aparecem indiretamente no vínculo e na frustração. Convém diferenciar o impacto subjetivo da condição de base, a adaptação ao tratamento e efeitos de contexto, como afastamentos, dependência prática de terceiros ou mudanças no papel familiar.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Ofatumumabe é um biológico usado em tratamento contínuo, mais frequentemente em esclerose múltipla, e tende a chegar ao consultório menos pelos efeitos subjetivos diretos do medicamento do que pela experiência de viver com uma doença crônica e com um regime regular de aplicação e monitoramento. Nas primeiras semanas, podem ganhar relevo apreensão com o início, vigilância corporal aumentada e reorganização da rotina; ao longo dos meses, costumam pesar mais a oscilação entre estabilidade e medo de piora, a fadiga atribuída de modos diferentes e o impacto na identidade. O ponto central na sessão é discriminar sofrimento ligado ao tratamento, à condição de base e a eventos de vida, sem supor causalidade.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe um sintoma ou sensação nova, isso costuma aparecer mais como medo do que pode acontecer, como limitação concreta no seu dia, ou como lembrança de fases anteriores da doença? , Nos períodos em que o tratamento entra mais no centro da sua rotina, você se sente mais sobrecarregado pela logística e pela vigilância, ou mais abatido por uma sensação de perda de autonomia? , Quando você diz que está mais cansado, esse cansaço se parece mais com exaustão física, com desânimo emocional, ou com esforço de ficar o tempo todo monitorando o corpo? , Nas semanas em que você se sente mais apreensivo, houve alguma mudança concreta na sua rotina de tratamento ou isso cresce mesmo sem mudança objetiva, a partir de pensamentos e antecipações?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente traz dificuldade recorrente para manter a regularidade do tratamento
- evita aplicações ou passa a adiar etapas de acompanhamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o impacto clínico dessa adesão irregular
- Quando surgem sintomas físicos novos ou claramente intensificados que o paciente associa ao tratamento ou à doença e isso altera funcionamento
- pode valer comunicação para checagem médica e melhor discriminação do quadro
- Quando a apreensão com o tratamento ou com a progressão da condição passa a dominar a rotina
- com retraimento importante ou abandono de atividades
- pode valer contato para coordenar leitura clínica do momento
- Quando o paciente relata intercorrência infecciosa relevante
- mal-estar persistente ou interrupções não planejadas no tratamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para atualização do contexto clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem na sessão sinais de confusão aguda
- rebaixamento importante do estado geral
- falta de ar
- febre alta ou piora física rápida.: Interromper o manejo exclusivamente psicoterápico e acionar avaliação médica no mesmo dia
- com rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente relata ideia suicida com intenção
- plano ou perda de controle
- especialmente em contexto de piora funcional ou sensação de futuro interrompido pela doença.: Fazer manejo de risco imediatamente
- acionar rede de apoio e avaliação urgente
- além de comunicar os assistentes envolvidos conforme necessidade clínica

Frase clínica

O foco costuma ser menos o biológico em si e mais como tratamento contínuo, incerteza e identidade reorganizam a vida psíquica do paciente.

149 TERIFLUNOMIDA

Substância: Teriflunomida.

Nomes Comerciais: Teriflunomida, Emnyra, Aubagio

Uso comum

- Teriflunomida é um imunomodulador usado sobretudo na esclerose múltipla, contexto menos frequente no consultório de psicoterapia do que os psicofármacos usuais. Para o terapeuta, o foco tende a ser menos um efeito subjetivo específico da medicação e mais como o tratamento contínuo de uma condição neurológica crônica reorganiza rotina, autonomia, trabalho, planos e identidade. Nas primeiras semanas a meses após início ou troca, vale observar se surgem mudanças percebidas em energia, humor, tolerância corporal ao tratamento ou preocupação com exames e acompanhamento médico. Ao longo do tempo, a sessão costuma girar em torno da carga do tratamento, medo de progressão, adesão e impacto funcional.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como presença constante na vida do paciente: exames, consultas, vigilância do corpo, planejamento da rotina e sensação de viver sob monitoramento. Isso às vezes aparece como irritabilidade, cansaço de falar sobre saúde ou empobrecimento do espaço psíquico para outros temas. Pode ser confundido com desânimo depressivo, mas a diferença costuma aparecer quando o sofrimento se organiza em torno da condição e do tratamento, e não como perda global de interesse em várias áreas.

Funcionalidade e identidade: Em pacientes com esclerose múltipla, oscilações de disposição, identificação, insegurança corporal ou receio de piora podem alterar a forma como a pessoa se percebe no trabalho, nos vínculos e na autonomia cotidiana. Na sessão, isso pode surgir como luto pela linha de base anterior, hipervigilância a sinais físicos ou retraimento por medo de depender dos outros. Nem toda queda de rendimento decorre da medicação; surtos da condição, fadiga associada à doença, eventos de vida e sobrecarga emocional podem produzir quadro semelhante.

Humor e ansiedade: Ansiedade antecipatória, medo de progressão, preocupação com exames e oscilação de humor podem ganhar relevo, especialmente em fases de início de tratamento, mudança de conduta ou após intercorrências clínicas. O terapeuta pode notar maior foco em cenários futuros, dificuldade de simbolizar e tendência a ler qualquer sensação corporal como sinal de agravamento. Também aqui a leitura pede cautela: parte do que aparece pode acompanhar a adaptação a uma doença crônica, e parte pode refletir sofrimento psíquico prévio ou reações a perdas concretas recentes."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como presença constante na vida do paciente: exames, consultas, vigilância do corpo, planejamento da rotina e sensação de viver sob monitoramento. Isso às vezes aparece como irritabilidade, cansaço de falar sobre saúde ou empobrecimento do espaço psíquico para outros temas. Pode ser confundido com desânimo depressivo, mas a diferença costuma aparecer quando o sofrimento se organiza em torno da condição e do tratamento, e não como perda global de interesse em várias áreas.

Funcionalidade e identidade: Em pacientes com esclerose múltipla, oscilações de disposição, identificação, insegurança corporal ou receio de piora podem alterar a forma como a pessoa se percebe no trabalho, nos vínculos e na autonomia cotidiana. Na sessão, isso pode surgir como luto pela linha de base anterior, hipervigilância a sinais físicos ou retraimento por medo de depender dos outros. Nem toda queda de rendimento decorre da medicação; surtos da condição, fadiga associada à doença, eventos de vida e sobrecarga emocional podem produzir quadro semelhante.

Humor e ansiedade: Ansiedade antecipatória, medo de progressão, preocupação com exames e oscilação de humor podem ganhar relevo, especialmente em fases de início de tratamento, mudança de conduta ou após intercorrências clínicas. O terapeuta pode notar maior foco em cenários futuros, dificuldade de simbolizar e tendência a ler qualquer sensação corporal como sinal de agravamento. Também aqui a leitura pede cautela: parte do que aparece pode acompanhar a adaptação a uma doença crônica, e parte pode refletir sofrimento psíquico prévio ou reações a perdas concretas recentes.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Teriflunomida é um imunomodulador usado sobretudo na esclerose múltipla, contexto menos frequente no consultório de psicoterapia do que os psicofármacos usuais. Para o terapeuta, o foco tende a ser menos um efeito subjetivo específico da medicação e mais como o tratamento contínuo de uma condição neurológica crônica reorganiza rotina, autonomia, trabalho, planos e identidade. Nas primeiras semanas a meses após início ou troca, vale observar se surgem mudanças percebidas em energia, humor, tolerância corporal ao tratamento ou preocupação com exames e acompanhamento médico. Ao longo do tempo, a sessão costuma girar em torno da carga do tratamento, medo de progressão, adesão e impacto funcional.

Perguntas úteis

- "Quando você percebeu essa mudança no seu humor ou na sua disposição, ela veio junto de alguma etapa do tratamento ou apareceu mais ligada a acontecimentos da sua vida fora da doença? , Nos dias em que você se sente pior, o que pesa mais: medo do que pode acontecer com a doença, efeitos corporais do tratamento, ou um desânimo mais geral que atinge tudo? , Quando você evita planos, trabalho ou encontros, isso parece vir mais de cansaço e insegurança física, ou de perda de vontade e prazer mesmo quando o corpo permitiria? , As preocupações que aparecem na sessão ficam concentradas em exames, sintomas e acompanhamento, ou se espalham para várias áreas da vida do mesmo jeito? , Você tem conseguido manter o tratamento como combinado ou houve períodos em que pulou, adiou ou pensou em interromper por conta do que estava sentindo?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar piora importante do funcionamento cotidiano associada temporalmente ao início do tratamento ou a mudanças recentes no acompanhamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar melhor o que pertence à condição de base e o que está interferindo na adesão
- Quando surgem medo intenso
- evitação ou sofrimento persistente ligados ao tratamento a ponto de o paciente cogitar interrompê-lo silenciosamente
- pode valer comunicar o médico para reduzir risco de abandono sem acompanhamento
- Quando aparecem alterações de humor ou ansiedade que se intensificam nas primeiras semanas a meses e fogem do padrão habitual do paciente
- pode valer contato com o médico assistente para contextualização clínica
- Quando o paciente traz sinais físicos novos ou marcadamente piores junto de queda funcional relevante
- pode valer alinhar com a equipe médica porque a distinção entre efeito do tratamento e atividade da doença não se resolve na psicoterapia
- Quando a sessão passa a ser dominada por desesperança
- sensação de perda acelerada de autonomia ou retraimento importante após intercorrência neurológica
- pode valer comunicação com o médico para articulação do cuidado

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem ideias de morte
- desesperança intensa ou fala de que a vida deixou de valer a pena
- especialmente junto de piora clínica recente.: Fazer avaliação de risco na hora
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- recorrendo à emergência se necessário
- Na sessão
- o paciente descreve piora física aguda importante
- confusão incomum ou incapacidade súbita de sustentar atividades básicas em comparação com sua linha de base.: Interromper a exploração psicoterápica habitual e orientar busca de avaliação médica imediata
- com acionamento de suporte emergencial se houver risco

Frase clínica

Com teriflunomida, o foco terapêutico costuma estar menos no fármaco e mais na carga psíquica de viver e tratar uma condição neurológica crônica.

150 TETRAIDROCANABINOL; CANABIDIOL

Substância: Tetraidrocanabinol; Canabidiol.

Nomes Comerciais: Mevatyl

Uso comum

- Combinação de tetraidrocanabinol e canabidiol, mais conhecida no consultório pelo uso em condições neurológicas crônicas, especialmente quando há espasticidade, dor, sono fragmentado e impacto funcional persistente. Para o terapeuta, o foco costuma ser menos um “efeito psiquiátrico esperado” e mais como o paciente em tratamento contínuo chega à sessão: oscilação de clareza mental, cansaço, variação de ansiedade, sensação de estranhamento corporal e mudanças na rotina. Nas primeiras semanas e após mudanças recentes no uso, vale observar com mais atenção tontura, lentificação, sonolência e alteração subjetiva de percepção; ao longo dos meses, o ponto central passa a ser adesão, funcionalidade e custo psíquico de viver com uma condição crônica tratada com medicação de controle especial.

O paciente pode relatar

- **"Clareza mental:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer fala mais lenta, dificuldade de sustentar o fio associativo, lapsos de memória recente ou sensação de estar “meio fora”. Isso pode se confundir com fadiga da condição de base, privação de sono, dor persistente ou uso concomitante de outras medicações sedativas. Vale comparar com a baseline do paciente e perguntar pela distribuição desses momentos ao longo do dia, porque uma oscilação mais ligada ao horário de uso costuma ter leitura diferente de um rebaixamento cognitivo mais contínuo.

Ansiedade e estranhamento: Alguns pacientes descrevem aumento de apreensão, desconforto corporal, sensação de irrealidade ou maior sensibilidade a estímulos, sobretudo no início do tratamento ou em períodos de ajuste recente. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, reatividade a eventos de vida ou até hipervigilância associada à própria doença crônica. A discriminação clínica depende de notar se o fenômeno aparece como algo novo no padrão subjetivo, mais corporal e abrupto, ou se mantém a assinatura emocional já conhecida do paciente.

Sono e sedação: Sonolência, cansaço diurno e redução do ritmo podem aparecer e alterar a qualidade do trabalho terapêutico, com menor acesso associativo e mais dificuldade de elaboração em sessão. Ao mesmo tempo, alguns pacientes dormem melhor quando sintomas físicos noturnos diminuem, o que pode melhorar humor e tolerância emocional. O ponto de confusão é que sedação medicamentosa, alívio de exaustão acumulada e piora depressiva podem produzir apresentações parecidas; por isso, ajuda observar se há melhora do descanso com queda de energia apenas em certos períodos ou um apagamento mais global do funcionamento.

Funcionalidade e autonomia: Como costuma entrar em contextos de doença crônica, o impacto subjetivo frequentemente passa por dependência de rotina rígida, limitação física, medo de piora e negociação constante entre autonomia e necessidade de cuidado. O paciente pode chegar menos disponível para elaboração profunda não por resistência, mas por estar absorvido pelo manejo diário do corpo e do tratamento. Isso pode ser confundido com evitamento psicológico, quando às vezes se trata de sobrecarga concreta e flutuação funcional real.

Adesão e manejo: Por ser medicação de controle especial e frequentemente inserida em tratamentos longos, podem surgir uso irregular, interrupções silenciosas, receio de julgamento, custo elevado ou ambivalência em relação ao benefício percebido. Na sessão, isso aparece como narrativa oscilante sobre melhora, piora e tolerabilidade, às vezes sem uma linha temporal clara. Quando o terapeuta reconstrói com o paciente o encadeamento entre início, interrupções, sintomas e rotina, costuma ficar mais fácil diferenciar efeito do tratamento, curso da condição de base e dificuldades práticas de adesão."

O que observar em sessão

- **Clareza mental:** Em parte dos pacientes, a sessão pode trazer fala mais lenta, dificuldade de sustentar o fio associativo, lapsos de memória recente ou sensação de estar “meio fora”. Isso pode se confundir com fadiga da condição de base, privação de sono, dor persistente ou uso concomitante de outras medicações sedativas. Vale comparar com a baseline do paciente e perguntar pela distribuição desses momentos ao longo do dia, porque uma oscilação mais ligada ao horário de uso costuma ter leitura diferente de um rebaixamento cognitivo mais contínuo.

Ansiedade e estranhamento: Alguns pacientes descrevem aumento de apreensão, desconforto corporal, sensação de irrealidade ou maior sensibilidade a estímulos, sobretudo no início do tratamento ou em períodos de ajuste recente. Na sessão, isso pode parecer ansiedade habitual, reatividade a eventos de vida ou até hipervigilância associada à própria doença crônica. A discriminação clínica depende de notar se o fenômeno aparece como algo novo no padrão subjetivo, mais corporal e abrupto, ou se mantém a assinatura emocional já conhecida do paciente.

Sono e sedação: Sonolência, cansaço diurno e redução do ritmo podem aparecer e alterar a qualidade do trabalho terapêutico, com menor acesso associativo e mais dificuldade de elaboração em sessão. Ao mesmo tempo, alguns pacientes dormem melhor quando sintomas físicos noturnos diminuem, o que pode melhorar humor e tolerância emocional. O ponto de confusão é que sedação medicamentosa, alívio de exaustão acumulada e piora depressiva podem produzir apresentações parecidas; por isso, ajuda observar se há melhora do descanso com queda de energia apenas em certos períodos ou um apagamento mais global do funcionamento.

Funcionalidade e autonomia: Como costuma entrar em contextos de doença crônica, o impacto subjetivo frequentemente passa por dependência de rotina rígida, limitação física, medo de piora e negociação constante entre autonomia e necessidade de cuidado. O paciente pode chegar menos disponível para elaboração profunda não por resistência, mas por estar absorvido pelo manejo diário do corpo e do tratamento. Isso pode ser confundido com evitamento psicológico, quando às vezes se trata de sobrecarga concreta e flutuação funcional real.

Adesão e manejo: Por ser medicação de controle especial e frequentemente inserida em tratamentos longos, podem surgir uso irregular, interrupções silenciosas, receio de julgamento, custo elevado ou ambivalência em relação ao benefício percebido. Na sessão, isso aparece como narrativa oscilante sobre melhora, piora e tolerabilidade, às vezes sem uma linha temporal clara. Quando o terapeuta reconstrói com o paciente o encadeamento entre início, interrupções, sintomas e rotina, costuma ficar mais fácil diferenciar efeito do tratamento, curso da condição de base e dificuldades práticas de adesão.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Combinação de tetraidrocannabinol e canabidiol, mais conhecida no consultório pelo uso em condições neurológicas crônicas, especialmente quando há espasticidade, dor, sono fragmentado e impacto funcional persistente. Para o terapeuta, o foco costuma ser menos um “efeito psiquiátrico esperado” e mais como o paciente em tratamento contínuo chega à sessão: oscilação de clareza mental, cansaço, variação de ansiedade, sensação de estranhamento corporal e mudanças na rotina. Nas primeiras semanas e após mudanças recentes no uso, vale observar com mais atenção tontura, lentificação, sonolência e alteração subjetiva de percepção; ao longo dos meses, o ponto central passa a ser adesão, funcionalidade e custo psíquico de viver com uma condição crônica tratada com medicação de controle especial.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou “fora do eixo”, isso costuma aparecer em momentos previsíveis do dia ou fica parecido o tempo todo? , Essa ansiedade ou estranheza que você percebe tem a mesma cara da sua ansiedade de costume, ou parece mais corporal, súbita e diferente do seu padrão? , Nos dias em que você fica mais sonolento, você sente que dormiu melhor e está mais descansado, ou é um cansaço que vem junto com apagamento e dificuldade de pensar? , Quando você nota piora ou melhora, isso acompanha mudanças na sua dor, no sono e na rotina, ou parece acontecer sem relação clara com esses fatores? , O que mudou na sua vida prática desde que esse tratamento entrou: você se sente mais funcional, mais dependente de organização, ou evitando atividades por receio de como vai ficar?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito lentificado
- confuso ou com prejuízo claro de memória recente em comparação com a própria baseline
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer tolerabilidade e segurança funcional
- Quando surgem ansiedade intensa
- sensação de estranhamento ou piora importante do sono logo após início recente ou retomada do uso
- pode valer comunicar o médico para diferenciar efeito do tratamento de agravamento do quadro de base
- Quando o paciente relata interrupções
- retomadas ou uso muito irregular e a leitura clínica fica embaralhada entre melhora
- piora e efeitos subjetivos
- pode valer alinhar com o médico para situar o momento do tratamento
- Quando a sedação começa a comprometer trabalho
- direção
- autocuidado ou presença mínima na sessão
- pode valer comunicação com o médico assistente pela repercussão funcional
- Quando há benefício físico parcial

Amarelo: alinhar em breve

- mas o custo subjetivo em clareza mental
- ansiedade ou rotina leva o paciente a considerar abandono silencioso
- pode valer alinhar com o médico para evitar ruptura não comunicada do tratamento

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente está desorganizado a ponto de não conseguir se orientar minimamente
- manter contato coerente ou relatar com consistência o que usou e como chegou ali.: Interromper o trabalho interpretativo
- priorizar segurança imediata
- acionar rede de apoio e avaliação médica no mesmo dia; emergência se houver risco concreto
- Aparecem ideação suicida com intenção ou plano
- rebaixamento importante do juízo crítico ou combinação de confusão intensa com incapacidade de autocuidado.: Fazer manejo de crise
- não deixar o paciente sem suporte
- acionar rede de apoio e avaliação médica urgente no mesmo dia

Frase clínica

O foco clínico é distinguir oscilação de clareza, ansiedade e funcionalidade do peso da condição crônica e do uso irregular do tratamento.

151 ÁCIDO FUMÁRICO SIPONIMODE

Substância: Ácido Fumárico Siponimode.

Nomes Comerciais: Kiendra

Uso comum

- Siponimode é um imunomodulador usado em esclerose múltipla, situação pouco frequente no consultório de terapia como foco medicamentoso em si. Para o terapeuta, o mais útil costuma ser acompanhar como um tratamento contínuo para uma doença neurológica crônica reorganiza rotina, autonomia, identidade e expectativa de futuro. Ao longo de semanas e meses, podem ganhar relevo oscilações de fadiga, atenção, humor e tolerância à incerteza, nem sempre fáceis de separar entre curso da doença, impacto emocional do diagnóstico, intercorrências clínicas e exigências do tratamento. O ponto central na sessão é sustentar discriminação clínica sem reduzir mudanças subjetivas ao remédio.

O paciente pode relatar

- "Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão menos como tema farmacológico e mais como presença constante na vida do paciente: consultas, exames, monitoramento, medo de progressão e necessidade de reorganizar agenda e energia. Isso pode aparecer como cansaço com o próprio cuidado, irritabilidade com a rotina médica ou oscilação entre hipercontrole e evitação. Vale não atribuir automaticamente esse peso ao medicamento, porque parte importante do sofrimento pode decorrer da condição de base, de surtos prévios, de limitações funcionais ou do modo como a pessoa vive a dependência de cuidados continuados.

Funcionalidade e identidade: Mudanças em mobilidade, resistência física, velocidade de processamento ou autonomia podem repercutir na autoestima e no lugar que o paciente ocupa em casa e no trabalho. Na sessão, às vezes surgem luto pela linha de base anterior, vergonha de precisar de ajuda ou esforço para parecer normal, o que pode mascarar exaustão real. Também aqui a leitura pode se confundir: um dia pior não indica necessariamente progressão, assim como um período mais produtivo não significa resolução do conflito emocional ligado à doença.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, exames e decisões de seguimento pode aparecer marcada por confiança, dependência, desconfiança ou afastamento defensivo. Alguns pacientes minimizam sintomas para não ocupar o lugar de doente; outros passam a vigiar o corpo de forma intensa, trazendo para a sessão uma busca de garantia que o setting não consegue oferecer. Quando isso ocorre, ajuda discriminar se se trata de ansiedade diante da incerteza, experiência prévia ruim com cuidados de saúde ou dificuldade mais ampla de adesão e comunicação em contextos de vulnerabilidade."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão menos como tema farmacológico e mais como presença constante na vida do paciente: consultas, exames, monitoramento, medo de progressão e necessidade de reorganizar agenda e energia. Isso pode aparecer como cansaço com o próprio cuidado, irritabilidade com a rotina médica ou oscilação entre hipercontrole e evitação. Vale não atribuir automaticamente esse peso ao medicamento, porque parte importante do sofrimento pode decorrer da condição de base, de surtos prévios, de limitações funcionais ou do modo como a pessoa vive a dependência de cuidados continuados.

Funcionalidade e identidade: Mudanças em mobilidade, resistência física, velocidade de processamento ou autonomia podem repercutir na autoestima e no lugar que o paciente ocupa em casa e no trabalho. Na sessão, às vezes surgem luto pela linha de base anterior, vergonha de precisar de ajuda ou esforço para parecer "normal", o que pode mascarar exaustão real. Também aqui a leitura pode se confundir: um dia pior não indica necessariamente progressão, assim como um período mais produtivo não significa resolução do conflito emocional ligado à doença.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, exames e decisões de seguimento pode aparecer marcada por confiança, dependência, desconfiança ou afastamento defensivo. Alguns pacientes minimizam sintomas para não ocupar o lugar de doente; outros passam a vigiar o corpo de forma intensa, trazendo para a sessão uma busca de garantia que o setting não consegue oferecer. Quando isso ocorre, ajuda discriminar se se trata de ansiedade diante da incerteza, experiência prévia ruim com cuidados de saúde ou dificuldade mais ampla de adesão e comunicação em contextos de vulnerabilidade.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Siponimode é um imunomodulador usado em esclerose múltipla, situação pouco frequente no consultório de terapia como foco medicamentoso em si. Para o terapeuta, o mais útil costuma ser acompanhar como um tratamento contínuo para uma doença neurológica crônica reorganiza rotina, autonomia, identidade e expectativa de futuro. Ao longo de semanas e meses, podem ganhar relevo oscilações de fadiga, atenção, humor e tolerância à incerteza, nem sempre fáceis de separar entre curso da doença, impacto emocional do diagnóstico, intercorrências clínicas e exigências do tratamento. O ponto central na sessão é sustentar discriminação clínica sem reduzir mudanças subjetivas ao remédio.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe uma piora, ela costuma vir junto de sinais corporais mais claros e limitação concreta no dia, ou aparece mais como medo antecipado de que algo vá piorar? , Nos períodos em que você se afasta de consultas, exames ou conversas sobre o tratamento, isso parece mais uma tentativa de descansar do tema ou um movimento de evitar algo que você teme encontrar? , Quando você diz que está mais cansado, esse cansaço se parece com sono, com lentificação para pensar, com desânimo emocional ou com esforço físico maior para fazer o que antes era simples? , Quando você se mostra mais produtivo ou animado, isso vem com sensação de retomada consistente da rotina ou com pressão para provar que a doença não está interferindo? , O que mais pesa hoje: os sintomas em si, a incerteza sobre o futuro ou a sensação de depender de uma rotina de cuidados que você não escolheu?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar piora funcional persistente
- novos limites concretos no cotidiano ou mudança corporal que interfere claramente na rotina
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar se há necessidade de reavaliação clínica
- Quando a adesão ao acompanhamento médico fica irregular
- com faltas repetidas
- interrupções não esclarecidas ou evitação importante do tema
- pode valer comunicar para reduzir risco de seguimento fragmentado
- Quando surgem humor muito rebaixado
- desesperança crescente ou retraimento importante em torno da doença e do tratamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para compor leitura clínica do momento
- Quando o paciente traz medo intenso de progressão ou vigilância corporal que passa a dominar a sessão
- pode valer contato com a equipe para integrar informações e evitar leituras desencontradas do quadro
- Quando familiares ou cuidadores relatam mudança cognitiva ou funcional mais marcada do que o próprio paciente reconhece
- pode valer comunicação com o médico assistente para checagem clínica mais próxima

Vermelho: tratar como urgência

- Ideias de morte
- desesperança intensa ou fala de que a vida deixou de valer a pena no contexto de piora da doença ou do tratamento.: Fazer avaliação de risco na própria sessão e acionar no mesmo dia rede de apoio
- médico assistente e emergência quando necessário
- Confusão aguda

Vermelho: tratar como urgência

- desorientação
- alteração importante do estado mental ou piora neurológica súbita percebida na sessão ou imediatamente antes dela.: Interromper a condução habitual da sessão e orientar busca de avaliação médica urgente
- acionando acompanhante e emergência se necessário

Frase clínica

O foco clínico é distinguir efeito do tratamento, curso da esclerose múltipla e sofrimento psíquico de viver sob cuidado contínuo.

152 NICOTINA

Substância: Nicotina.

Nomes Comerciais: Nicorette, Niquitin

Uso comum

- Nicotina em reposição costuma aparecer no consultório quando o paciente está tentando reduzir ou interromper o tabagismo. Não é um psicofármaco, mas pode alterar de forma perceptível irritabilidade, ansiedade, sono, concentração e apetite nas primeiras 1 a 4 semanas, período em que também se misturam sintomas de abstinência, expectativa de fracasso, ganho de autonomia e recaídas pontuais. Na sessão, o ponto central não é atribuir tudo ao produto, e sim acompanhar o padrão temporal: o que mudou desde a redução do cigarro, o que varia ao longo do dia e o que sugere uso irregular, fissura ou retorno silencioso ao tabaco.

O paciente pode relatar

- **"Fissura e ansiedade:** Nas primeiras semanas, a sessão pode trazer urgência para fumar, irritabilidade, inquietação e sensação de estar "mais ansioso". Isso pode se parecer com piora do quadro ansioso de base, mas às vezes acompanha horários previsíveis, situações-gatilho ou intervalos maiores sem nicotina. Vale observar se a ativação aparece como tensão ligada à fissura e ao hábito interrompido, ou se mantém o mesmo desenho da ansiedade habitual do paciente, independentemente do contexto do tabagismo.

Humor e irritabilidade: Oscilações de humor, impaciência e menor tolerância à frustração são comuns nesse período e podem entrar na sessão como conflitos interpessoais, sensação de estar "sem filtro" ou desânimo por não conseguir parar. A leitura pode se confundir com estresse de vida, frustração narcísica diante de recaídas ou reemergência depressiva. O que ajuda é mapear se houve mudança de baseline após a tentativa de cessação e se a irritabilidade melhora quando a fissura cede ou quando o paciente volta a fumar.

Sono e ativação: Alguns pacientes chegam mais agitados à noite, com dificuldade para pegar no sono, sono fragmentado ou sonhos vívidos, enquanto outros relatam cansaço por noites ruins durante a tentativa de parar de fumar. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como insônia primária, piora ansiosa ou efeito de outras substâncias, especialmente cafeína e álcool. A discriminação clínica depende do encadeamento temporal entre mudança no padrão de nicotina, horários de uso, recaídas e piora do descanso.

Concentração e ritmo: Queda de foco, sensação de lentificação ou dificuldade de sustentar tarefas podem aparecer quando o paciente reduz o cigarro e ainda não encontrou um novo equilíbrio. Isso pode ser confundido com TDAH, piora depressiva, sobrecarga ocupacional ou privação de sono. Na sessão, vale notar se a dificuldade cognitiva é mais situacional, associada à fissura e à abstinência, ou se mantém a mesma qualidade e amplitude que já existiam antes da mudança no tabagismo.

Apetite e manejo oral: Aumento do apetite, busca por beliscar, ganho de peso temido e necessidade de ocupar a boca ou as mãos costumam ter peso subjetivo importante e podem ameaçar a adesão silenciosamente. O paciente pode apresentar isso como "falta de controle", quando às vezes se trata de substituição comportamental da rotina do cigarro e de medo de engordar. Esse domínio merece atenção porque pode deslocar a conversa do tabagismo para vergonha corporal, autoimagem e abandono precoce da tentativa.

Adesão e recaída: Uso irregular da reposição, interrupções por conta própria, combinação com cigarros e recaídas parciais são frequentes e nem sempre aparecem espontaneamente, sobretudo quando o paciente teme julgamento. Na sessão, isso pode ser confundido com "tratamento que não funciona" ou com falta de motivação global. O mais útil é acompanhar o processo como oscilante: dias bons, lapsos, retorno ao cigarro em situações específicas e mudanças no vínculo do paciente com a própria tentativa de parar."

O que observar em sessão

- **Fissura e ansiedade:** Nas primeiras semanas, a sessão pode trazer urgência para fumar, irritabilidade, inquietação e sensação de estar “mais ansioso”. Isso pode se parecer com piora do quadro ansioso de base, mas às vezes acompanha horários previsíveis, situações-gatilho ou intervalos maiores sem nicotina. Vale observar se a ativação aparece como tensão ligada à fissura e ao hábito interrompido, ou se mantém o mesmo desenho da ansiedade habitual do paciente, independentemente do contexto do tabagismo.

Humor e irritabilidade: Oscilações de humor, impaciência e menor tolerância à frustração são comuns nesse período e podem entrar na sessão como conflitos interpessoais, sensação de estar “sem filtro” ou desânimo por não conseguir parar. A leitura pode se confundir com estresse de vida, frustração narcísica diante de recaídas ou reemergência depressiva. O que ajuda é mapear se houve mudança de baseline após a tentativa de cessação e se a irritabilidade melhora quando a fissura cede ou quando o paciente volta a fumar.

Sono e ativação: Alguns pacientes chegam mais agitados à noite, com dificuldade para pegar no sono, sono fragmentado ou sonhos vívidos, enquanto outros relatam cansaço por noites ruins durante a tentativa de parar de fumar. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como insônia primária, piora ansiosa ou efeito de outras substâncias, especialmente cafeína e álcool. A discriminação clínica depende do encadeamento temporal entre mudança no padrão de nicotina, horários de uso, recaídas e piora do descanso.

Concentração e ritmo: Queda de foco, sensação de lentificação ou dificuldade de sustentar tarefas podem aparecer quando o paciente reduz o cigarro e ainda não encontrou um novo equilíbrio. Isso pode ser confundido com TDAH, piora depressiva, sobrecarga ocupacional ou privação de sono. Na sessão, vale notar se a dificuldade cognitiva é mais situacional, associada à fissura e à abstinência, ou se mantém a mesma qualidade e amplitude que já existiam antes da mudança no tabagismo.

Apetite e manejo oral: Aumento do apetite, busca por beliscar, ganho de peso temido e necessidade de ocupar a boca ou as mãos costumam ter peso subjetivo importante e podem ameaçar a adesão silenciosamente. O paciente pode apresentar isso como “falta de controle”, quando às vezes se trata de substituição comportamental da rotina do cigarro e de medo de engordar. Esse domínio merece atenção porque pode deslocar a conversa do tabagismo para vergonha corporal, autoimagem e abandono precoce da tentativa.

Adesão e recaída: Uso irregular da reposição, interrupções por conta própria, combinação com cigarros e recaídas parciais são frequentes e nem sempre aparecem espontaneamente, sobretudo quando o paciente teme julgamento. Na sessão, isso pode ser confundido com “tratamento que não funciona” ou com falta de motivação global. O mais útil é acompanhar o processo como oscilante: dias bons, lapsos, retorno ao cigarro em situações específicas e mudanças no vínculo do paciente com a própria tentativa de parar.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Nicotina em reposição costuma aparecer no consultório quando o paciente está tentando reduzir ou interromper o tabagismo. Não é um psicofármaco, mas pode alterar de forma perceptível irritabilidade, ansiedade, sono, concentração e apetite nas primeiras 1 a 4 semanas, período em que também se misturam sintomas de abstinência, expectativa de fracasso, ganho de autonomia e recaídas pontuais. Na sessão, o ponto central não é atribuir tudo ao produto, e sim acompanhar o padrão temporal: o que mudou desde a redução do cigarro, o que varia ao longo do dia e o que sugere uso irregular, fissura ou retorno silencioso ao tabaco.

Perguntas úteis

- "Quando a irritação ou a ansiedade aparecem, isso costuma vir junto de vontade de fumar ou surge do mesmo jeito mesmo quando a fissura não está presente? , Essas dificuldades de concentração começaram depois que você reduziu o cigarro, ou já tinham esse mesmo padrão antes? , Nos dias em que o sono piora, você percebe alguma relação com horários de uso da nicotina, recaída no cigarro, café ou maior tensão emocional? , Quando você diz que “não está funcionando”, o que aconteceu na prática: a vontade de fumar não diminuiu, você voltou a fumar em alguns momentos, ou o desconforto ficou difícil de sustentar? , Esse aumento de apetite parece mais fome física, vontade de mastigar algo, ou tentativa de aliviar nervosismo e vazio? , Quando houve recaída, ela veio como decisão consciente, impulso em situação específica, ou porque você já vinha se sentindo sobrecarregado há alguns dias?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente mantém irritabilidade
- ansiedade ou insônia em intensidade que compromete claramente a rotina após as primeiras semanas
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar se o quadro acompanha abstinência
- uso irregular ou outro fator clínico
- Quando surgem recaídas repetidas acompanhadas de vergonha e omissão do padrão real de uso
- pode valer comunicar o médico para que a condução considere adesão irregular e não apenas ausência de resposta
- Quando o paciente descreve piora importante do humor ou aumento de desesperança durante a tentativa de cessação
- pode valer alinhar com o médico para diferenciar sofrimento esperado do processo de um agravamento clínico mais amplo
- Quando há queixa persistente de palpitações
- mal-estar físico ou agitação marcante associada ao uso
- pode valer contato com o médico assistente para avaliação clínica
- sobretudo se isso estiver levando ao abandono da estratégia
- Quando a sessão mostra combinação frequente entre reposição de nicotina e retorno consistente ao cigarro sem que isso tenha sido discutido no seguimento médico

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar para contextualizar melhor o momento do tratamento

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- aparece ideação suicida atual
- aumento de autoagressão ou desesperança intensa durante a tentativa de cessação
- especialmente se houve piora recente do humor.: Fazer manejo clínico imediato do risco
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- com emergência quando necessário
- O paciente chega com agitação intensa
- mal-estar importante
- palpitações marcantes
- confusão ou sensação de que “tem algo muito errado” no corpo durante o uso.: Interromper a exploração psicoterápica e orientar busca de avaliação médica imediata
- acionando suporte de urgência se o estado geral estiver comprometido

Frase clínica

O foco clínico é separar abstinência, fissura e recaída de piora psicopatológica, acompanhando o padrão temporal da tentativa de parar de fumar.

153 TARTARATO DE VARENICLINA

Substância: Tartarato de Vareniclina.

Nomes Comerciais: Champix

Uso comum

- A vareniclina é um medicamento usado na cessação do tabagismo, e tende a aparecer no consultório quando o paciente está tentando reduzir ou interromper o cigarro. Nas primeiras 1 a 2 semanas, antes e ao redor da data escolhida para parar, costumam ficar mais visíveis oscilação de humor, irritabilidade, ansiedade, alteração do sono e sonhos vívidos; parte disso pode se confundir com abstinência de nicotina, expectativa em torno do tratamento e mudanças na rotina. Ao longo das semanas seguintes, o ponto central na sessão é discriminar o que acompanha a retirada do tabaco, o que coincide temporalmente com o início do medicamento e o que sinaliza sofrimento psíquico que merece alinhamento médico.

O paciente pode relatar

- **"Humor e irritabilidade:** Irritabilidade, labilidade emocional e piora transitória do humor podem aparecer no período de redução ou interrupção do cigarro. Na sessão, isso às vezes surge como menor tolerância à frustração, impaciência, reatividade aumentada e sensação de estar “sem filtro”. A leitura pode se confundir facilmente porque a abstinência de nicotina, conflitos familiares em torno da tentativa de parar e frustração com recaídas produzem um quadro muito parecido. Vale observar a relação temporal entre essas mudanças, o padrão prévio do paciente e se há intensificação desproporcional ao contexto.

Ansiedade e agitação: Alguns pacientes chegam mais tensos, inquietos ou com sensação de urgência interna nas primeiras semanas. Em sessão, isso pode parecer ansiedade antecipatória pela possibilidade de falhar, desconforto corporal ligado à fissura ou uma ativação menos habitual para aquele paciente. A distinção clínica importante é entre ansiedade já esperada na retirada do tabaco, aumento inespecífico de estresse de vida e uma mudança mais abrupta após o início do tratamento. Quando a inquietação vem acompanhada de redução importante do sono, aceleração e expansividade incomuns, a hipótese não deve ser lida apenas como ansiedade.

Sono e sonhos: Alterações do sono são relativamente salientes com vareniclina, sobretudo no começo: insônia, sono fragmentado e sonhos vívidos podem entrar no material da sessão. O terapeuta pode notar cansaço, menor capacidade de elaboração e maior irritabilidade, mas isso também pode decorrer da própria abstinência de nicotina ou de mudanças comportamentais associadas a parar de fumar, como aumento do consumo de café. A pergunta clínica central é se o sono piorou de modo novo e temporalmente próximo ao tratamento ou se já vinha comprometido antes. Sonhos intensos, por si, não indicam gravidade, mas ajudam a explicar mudanças no tônus da sessão.

Fissura e adesão: A experiência subjetiva de fissura nem sempre diminui de forma linear, e o paciente pode interpretar isso como “o remédio não está funcionando” e passar a usar de modo irregular ou abandonar silenciosamente. Na sessão, isso aparece como ambivalência, desânimo, racionalizações para retomar o cigarro ou omissão sobre recaídas por vergonha. Também é comum confundir oscilação normal do processo de cessação com ineficácia global do tratamento. Vale mapear se houve mudança no padrão de uso do cigarro, lapsos, interrupções do medicamento e como o paciente está significando esses eventos.

Náusea e tolerabilidade: Desconforto gastrointestinal, especialmente náusea, pode ganhar relevância clínica não pelo sintoma em si, mas porque interfere no vínculo do paciente com o tratamento e na disposição para mantê-lo. Em sessão, isso pode surgir como aversão ao medicamento, irritação, sensação de estar “passando mal” ou uso irregular sem comunicação ao médico. Esse quadro pode ser confundido com ansiedade somatizada, alimentação desorganizada ou mal-estar associado à própria mudança de rotina ao parar de fumar. Quando o desconforto vira motivo para abandono silencioso, o impacto clínico costuma ser maior do que a intensidade do sintoma.

Risco psíquico emergente: Embora muitos pacientes atravessem o processo apenas com desconfortos manejáveis, vale manter atenção para piora importante do humor, desesperança, impulsividade ou surgimento de pensamentos de morte durante a cessação. Na sessão, o

desafio é não atribuir automaticamente esses sinais ao medicamento nem reduzi-los a “nervosismo por parar de fumar”. Eventos de vida, história psiquiátrica prévia, uso de álcool e outras substâncias e recaídas recentes podem pesar mais do que um único fator. O foco é reconhecer mudança de baseline, avaliar urgência e decidir se cabe comunicação rápida com o médico assistente.”

O que observar em sessão

- **Humor e irritabilidade:** Irritabilidade, labilidade emocional e piora transitória do humor podem aparecer no período de redução ou interrupção do cigarro. Na sessão, isso às vezes surge como menor tolerância à frustração, impaciência, reatividade aumentada e sensação de estar “sem filtro”. A leitura pode se confundir facilmente porque a abstinência de nicotina, conflitos familiares em torno da tentativa de parar e frustração com recaídas produzem um quadro muito parecido. Vale observar a relação temporal entre essas mudanças, o padrão prévio do paciente e se há intensificação desproporcional ao contexto.

Ansiedade e agitação: Alguns pacientes chegam mais tensos, inquietos ou com sensação de urgência interna nas primeiras semanas. Em sessão, isso pode parecer ansiedade antecipatória pela possibilidade de falhar, desconforto corporal ligado à fissura ou uma ativação menos habitual para aquele paciente. A distinção clínica importante é entre ansiedade já esperada na retirada do tabaco, aumento inespecífico de estresse de vida e uma mudança mais abrupta após o início do tratamento. Quando a inquietação vem acompanhada de redução importante do sono, aceleração e expansividade incomuns, a hipótese não deve ser lida apenas como ansiedade.

Sono e sonhos: Alterações do sono são relativamente salientes com vareniclina, sobretudo no começo: insônia, sono fragmentado e sonhos vívidos podem entrar no material da sessão. O terapeuta pode notar cansaço, menor capacidade de elaboração e maior irritabilidade, mas isso também pode decorrer da própria abstinência de nicotina ou de mudanças comportamentais associadas a parar de fumar, como aumento do consumo de café. A pergunta clínica central é se o sono piorou de modo novo e temporalmente próximo ao tratamento ou se já vinha comprometido antes. Sonhos intensos, por si, não indicam gravidade, mas ajudam a explicar mudanças no tônus da sessão.

Fissura e adesão: A experiência subjetiva de fissura nem sempre diminui de forma linear, e o paciente pode interpretar isso como “o remédio não está funcionando” e passar a usar de modo irregular ou abandonar silenciosamente. Na sessão, isso aparece como ambivalência, desânimo, racionalizações para retomar o cigarro ou omissão sobre recaídas por vergonha. Também é comum confundir oscilação normal do processo de cessação com ineficácia global do tratamento. Vale mapear se houve mudança no padrão de uso do cigarro, lapsos, interrupções do medicamento e como o paciente está significando esses eventos.

Náusea e tolerabilidade: Desconforto gastrointestinal, especialmente náusea, pode ganhar relevância clínica não pelo sintoma em si, mas porque interfere no vínculo do paciente com o tratamento e na disposição para mantê-lo. Em sessão, isso pode surgir como aversão ao medicamento, irritação, sensação de estar “passando mal” ou uso irregular sem comunicação ao médico. Esse quadro pode ser confundido com ansiedade somatizada, alimentação desorganizada ou mal-estar associado à própria mudança de rotina ao parar de fumar. Quando o desconforto vira motivo para abandono silencioso, o impacto clínico costuma ser maior do que a intensidade do sintoma.

Risco psíquico emergente: Embora muitos pacientes atravessem o processo apenas com desconfortos manejáveis, vale manter atenção para piora importante do humor, desesperança, impulsividade ou surgimento de pensamentos de morte durante a cessação. Na sessão, o

desafio é não atribuir automaticamente esses sinais ao medicamento nem reduzi-los a “nervosismo por parar de fumar”. Eventos de vida, história psiquiátrica prévia, uso de álcool e outras substâncias e recaídas recentes podem pesar mais do que um único fator. O foco é reconhecer mudança de baseline, avaliar urgência e decidir se cabe comunicação rápida com o médico assistente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A vareniclina é um medicamento usado na cessação do tabagismo, e tende a aparecer no consultório quando o paciente está tentando reduzir ou interromper o cigarro. Nas primeiras 1 a 2 semanas, antes e ao redor da data escolhida para parar, costumam ficar mais visíveis oscilação de humor, irritabilidade, ansiedade, alteração do sono e sonhos vívidos; parte disso pode se confundir com abstinência de nicotina, expectativa em torno do tratamento e mudanças na rotina. Ao longo das semanas seguintes, o ponto central na sessão é discriminar o que acompanha a retirada do tabaco, o que coincide temporalmente com o início do medicamento e o que sinaliza sofrimento psíquico que merece alinhamento médico.

Perguntas úteis

- "Essas mudanças de humor começaram mais perto do início do tratamento, da redução do cigarro ou de algum acontecimento específico da sua semana? , Quando você fica mais agitado, isso se parece com a sua ansiedade habitual ou é uma sensação mais corporal, urgente e diferente do seu padrão? , O que mudou primeiro: a piora do sono, os sonhos intensos, a irritabilidade ou a fissura por fumar? , Nos dias em que você pensou em fumar ou fumou, isso veio mais como vontade física, como resposta a estresse emocional ou como sensação de fracasso com o processo? , Você percebe que está mais desanimado porque parar de fumar tem sido difícil, ou apareceu uma queda de humor mais ampla, que atinge também outras áreas da vida? , Desde que começou esse processo, houve dias em que você deixou de tomar o medicamento, tomou de modo irregular ou pensou em parar sem comentar com o médico?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta piora consistente do humor
- irritabilidade intensa ou ansiedade que foge do seu padrão nas primeiras semanas
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar a mudança no contexto da cessação e do tratamento
- Quando sonhos vívidos
- insônia ou náusea passam a comprometer adesão
- funcionamento diurno ou disposição para seguir no processo
- pode valer comunicar o médico para evitar abandono silencioso
- Quando o paciente retoma o cigarro
- oscila muito entre parar e voltar ou passa a usar o medicamento de forma irregular sem ter informado isso
- pode valer alinhar com o médico para contextualizar adesão e resposta clínica

Amarelo: alinhar em breve

- Quando surgem desesperança acentuada
- impulsividade
- autoagressão ou pensamentos de morte
- a comunicação com o médico assistente ganha prioridade pela necessidade de reavaliar segurança e condução do caso

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão aparecem pensamentos de morte
- autoagressão
- impulso de se machucar ou sensação de que perdeu o controle sobre o que pode fazer consigo.: Avaliar segurança imediatamente
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- recorrendo a emergência quando necessário
- Surge mudança abrupta com redução importante da necessidade de sono
- aceleração incomum
- fala muito pressionada
- grandiosidade ou comportamento marcadamente desorganizado para o padrão do paciente.: Tratar como alteração aguda do estado mental
- contatar o médico assistente no mesmo dia e acionar suporte de urgência se houver risco ou prejuízo importante de juízo crítico

Frase clínica

Na vareniclina, o foco clínico é separar abstinência de nicotina, efeito do tratamento e sofrimento psíquico emergente sem perder de vista a adesão.

154 BROMIDRATO DE GALANTAMINA

Substância: Bromidrato de Galantamina.

Nomes Comerciais: Bromidrato de Galantamina, Coglive, Gaudy, Regressa, Alzynamin, Cogit, Elatium

Uso comum

- A galantamina é um medicamento usado sobretudo em quadros demenciais, especialmente quando há queixas de memória, atenção e autonomia no dia a dia. No consultório de terapia, ela costuma aparecer mais como parte do contexto de um paciente em acompanhamento por declínio cognitivo do que como foco central da sessão. Nas primeiras semanas, vale observar se surgem mudanças no ritmo, no apetite, no sono ou maior desconforto corporal que interfiram na presença em sessão; ao longo de 1 a 3 meses, o ponto clínico principal passa a ser distinguir flutuação cognitiva esperável, progressão do quadro de base, intercorrências clínicas e adesão irregular. O foco do terapeuta é acompanhar como o paciente sustenta vínculo, narrativa e funcionalidade apesar da instabilidade cognitiva.

O paciente pode relatar

- **"Cognição em sessão:** O paciente pode chegar mais lento para recuperar palavras, perder o fio da narrativa, repetir trechos ou oscilar entre momentos de boa presença e maior confusão. Isso pode ser lido apressadamente como desinteresse, resistência ou piora linear, quando às vezes há flutuação do próprio quadro, cansaço, horário da sessão, sobrecarga ambiental ou uso irregular da medicação. Vale comparar com a linha de base recente e notar se a oscilação é intra-sessão, entre sessões ou associada a mudanças concretas na rotina.

Tolerabilidade inicial: No começo do uso, alguns pacientes ficam mais indispostos, com náusea, mal-estar, redução do apetite ou sensação de fraqueza, o que pode aparecer como menor disponibilidade psíquica, irritabilidade ou vontade de encurtar a sessão. Em terapia, isso pode se confundir com retraimento depressivo, luto pela perda funcional ou simples desmotivação para o tratamento. A observação útil é se a queda de presença coincide temporalmente com o início recente do medicamento e se vem acompanhada de desconforto corporal suficientemente incômodo para alterar rotina e alimentação.

Humor e reatividade: Em quadros demenciais, humor deprimido, ansiedade, apatia e irritabilidade frequentemente coexistem com o declínio cognitivo e com a experiência subjetiva de perda de autonomia. Mudanças emocionais após início ou retomada da galantamina podem ocorrer, mas também podem refletir frustração com falhas cognitivas, conflitos familiares, vergonha, maior consciência do déficit ou intercorrências clínicas. Na sessão, importa discriminar se houve mudança qualitativa do acesso afetivo e da reatividade ou se o afeto acompanha de modo compreensível o contexto de adoecimento.

Funcionalidade e autonomia: Pequenas mudanças em iniciativa, organização de tarefas, manejo de compromissos e tolerância a atividades cognitivamente exigentes costumam ser mais informativas do que uma impressão global de 'melhor' ou 'pior'. Às vezes a família percebe melhora enquanto o paciente se sente mais exposto às próprias limitações, ou o contrário. O terapeuta ganha precisão quando investiga exemplos concretos da semana e diferencia variação funcional sustentada de dias isolados, ajuda externa maior ou redução de demandas.

Adesão e rotina: Esquecimentos, recusas silenciosas, confusão com horários e interrupções não verbalizadas são plausíveis nesse contexto e podem alterar bastante o que aparece na sessão. Quando o padrão clínico muda de forma irregular, com semanas muito diferentes entre si, vale considerar adesão inconsistente, participação variável do cuidador, mudanças de rotina ou outras medicações em paralelo, sem presumir causalidade. A forma como o paciente e a família falam do tratamento também oferece pistas sobre negação, vergonha, sobrecarga ou conflito em torno da dependência."

O que observar em sessão

- **Cognição em sessão:** O paciente pode chegar mais lento para recuperar palavras, perder o fio da narrativa, repetir trechos ou oscilar entre momentos de boa presença e maior confusão. Isso pode ser lido apressadamente como desinteresse, resistência ou piora linear, quando às vezes há flutuação do próprio quadro, cansaço, horário da sessão, sobrecarga ambiental ou uso irregular da medicação. Vale comparar com a linha de base recente e notar se a oscilação é intra-sessão, entre sessões ou associada a mudanças concretas na rotina.

Tolerabilidade inicial: No começo do uso, alguns pacientes ficam mais indispostos, com náusea, mal-estar, redução do apetite ou sensação de fraqueza, o que pode aparecer como menor disponibilidade psíquica, irritabilidade ou vontade de encurtar a sessão. Em terapia, isso pode se confundir com retraimento depressivo, luto pela perda funcional ou simples desmotivação para o tratamento. A observação útil é se a queda de presença coincide temporalmente com o início recente do medicamento e se vem acompanhada de desconforto corporal suficientemente incômodo para alterar rotina e alimentação.

Humor e reatividade: Em quadros demenciais, humor deprimido, ansiedade, apatia e irritabilidade frequentemente coexistem com o declínio cognitivo e com a experiência subjetiva de perda de autonomia. Mudanças emocionais após início ou retomada da galantamina podem ocorrer, mas também podem refletir frustração com falhas cognitivas, conflitos familiares, vergonha, maior consciência do déficit ou intercorrências clínicas. Na sessão, importa discriminar se houve mudança qualitativa do acesso afetivo e da reatividade ou se o afeto acompanha de modo compreensível o contexto de adoecimento.

Funcionalidade e autonomia: Pequenas mudanças em iniciativa, organização de tarefas, manejo de compromissos e tolerância a atividades cognitivamente exigentes costumam ser mais informativas do que uma impressão global de 'melhor' ou 'pior'. Às vezes a família percebe melhora enquanto o paciente se sente mais exposto às próprias limitações, ou o contrário. O terapeuta ganha precisão quando investiga exemplos concretos da semana e diferencia variação funcional sustentada de dias isolados, ajuda externa maior ou redução de demandas.

Adesão e rotina: Esquecimentos, recusas silenciosas, confusão com horários e interrupções não verbalizadas são plausíveis nesse contexto e podem alterar bastante o que aparece na sessão. Quando o padrão clínico muda de forma irregular, com semanas muito diferentes entre si, vale considerar adesão inconsistente, participação variável do cuidador, mudanças de rotina ou outras medicações em paralelo, sem presumir causalidade. A forma como o paciente e a família falam do tratamento também oferece pistas sobre negação, vergonha, sobrecarga ou conflito em torno da dependência.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A galantamina é um medicamento usado sobretudo em quadros demenciais, especialmente quando há queixas de memória, atenção e autonomia no dia a dia. No consultório de terapia, ela costuma aparecer mais como parte do contexto de um paciente em acompanhamento por declínio cognitivo do que como foco central da sessão. Nas primeiras semanas, vale observar se surgem mudanças no ritmo, no apetite, no sono ou maior desconforto corporal que interfiram na presença em sessão; ao longo de 1 a 3 meses, o ponto clínico principal passa a ser distinguir flutuação cognitiva esperável, progressão do quadro de base, intercorrências clínicas e adesão irregular. O foco do terapeuta é acompanhar como o paciente sustenta vínculo, narrativa e funcionalidade apesar da instabilidade cognitiva.

Perguntas úteis

- "Quando você sente que está 'mais confuso', isso acontece o tempo todo ou em momentos específicos do dia ou da semana? , Desde que esse remédio entrou na rotina, o que mudou mais: sua memória e atenção, seu corpo e disposição, ou seu humor? , Nos dias em que você vem mais cansado ou menos presente, isso costuma vir junto com enjoo, pouco apetite ou mal-estar físico? , O que você consegue fazer nesta semana que estava mais difícil antes, e o que continua igual apesar do tratamento? , Quando uma semana vem muito diferente da outra, houve alguma mudança na rotina, ajuda da família ou na forma de tomar os remédios? , Quando você fica mais irritado ou desanimado, isso aparece depois de falhas de memória e frustração, ou parece surgir sem relação clara com essas situações?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- encurtar sessões ou reduzir muito a participação por mal-estar físico
- pouca alimentação ou indisposição após início recente
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se há baixa tolerabilidade interferindo na adesão
- Quando há oscilação cognitiva ou funcional mais acentuada do que a linha de base recente
- especialmente com confusão nova ou piora rápida em dias a poucas semanas
- pode valer comunicar o médico para diferenciar progressão do quadro
- intercorrência clínica e efeito do tratamento
- Quando o paciente ou a família deixam entrever esquecimentos frequentes
- interrupções por conta própria ou uso muito irregular
- pode valer alinhar com o médico assistente porque isso dificulta a leitura clínica da evolução
- Quando surgem desânimo importante
- irritabilidade incomum ou retraimento marcante após mudança recente no tratamento
- pode valer comunicar o médico para avaliação conjunta da temporalidade e do impacto funcional
- Quando aparecem episódios de tontura

Amarelo: alinhar em breve

- quase desmaio ou quedas associados a piora da presença em sessão
- pode valer contato com o médico assistente pela repercussão clínica e risco de segurança

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- o paciente parece prestes a desmaiar
- apresenta queda importante do nível de alerta ou refere episódio recente de desmaio com instabilidade atual.: Interromper o enquadre habitual
- acionar suporte imediato e buscar avaliação médica no mesmo dia
- Confusão aguda
- desorientação marcante ou mudança abrupta do estado mental em comparação com o padrão habitual.: Tratar como intercorrência clínica aguda
- contatar rede de apoio e encaminhar para avaliação médica imediata

Frase clínica

O foco clínico não é só memória: é distinguir flutuação cognitiva, progressão do quadro, tolerabilidade e adesão no que aparece na sessão.

155 CLORIDRATO DE DONEPEZILA

Substância: Cloridrato de Donepezila.

Nomes Comerciais: Don, Cloridrato de Donepezila, Labrea, Senes, Depzel, Epéz, Comfect, Donila, Furp-Donepezila, Eranz, Danpezil

Uso comum

- A donepezila é um medicamento usado sobretudo em quadros demenciais, especialmente doença de Alzheimer, e tende a chegar ao consultório mais pelo contexto de declínio cognitivo e cuidado contínuo do que por efeitos subjetivos facilmente nomeáveis. Nas primeiras semanas podem aparecer mudanças no sono, desconforto gastrointestinal, maior cansaço ou agitação, mas o ponto central para o terapeuta costuma ser acompanhar se houve mudança no padrão de atenção, orientação, tolerância à frustração e funcionalidade cotidiana após o início ou após mudanças recentes no tratamento. Em uso contínuo, vale observar flutuações entre sessões, impacto sobre autonomia, sobrecarga do cuidador e consistência da adesão, sem atribuir automaticamente piora ou melhora ao medicamento.

O paciente pode relatar

- **"Cognição no setting:** O paciente pode chegar mais lento, mais repetitivo, com dificuldade para sustentar o fio da conversa ou, em alguns casos, discretamente mais acessível e organizado do que na linha de base recente. Na sessão, interessa notar se a oscilação aparece como flutuação ao longo do encontro, se acompanha cansaço, horário da tomada, noites ruins ou intercorrências clínicas, porque isso pode confundir a leitura entre progressão do quadro, efeito inespecífico do tratamento e variação do dia. Mudanças abruptas chamam mais atenção do que diferenças pequenas e estáveis entre sessões.

Sono e vigília: Alterações de sono podem aparecer como sonhos vívidos, fragmentação do sono, sonolência diurna ou maior irritabilidade por noites mal dormidas. No consultório, isso pode se apresentar como menor tolerância à espera, queda de atenção, bocejos frequentes ou dificuldade de elaboração, o que facilmente se confunde com avanço do comprometimento cognitivo ou humor deprimido. Vale comparar com o padrão prévio e com a rotina recente, porque uma piora temporalmente próxima ao início do uso ou a mudanças na adesão pode ter peso clínico diferente de uma insônia crônica já conhecida.

Humor e irritabilidade: Em parte dos pacientes, o que aparece não é uma queixa cognitiva direta, mas mais impaciência, labilidade, retraimento ou desânimo diante das próprias falhas. O terapeuta pode observar aumento de reatividade emocional, vergonha, defensividade ou menor acesso afetivo, mas isso também pode decorrer da consciência do declínio, de conflitos familiares e da experiência de dependência crescente. A tarefa clínica é discriminar se houve mudança de tonalidade afetiva junto com o início do tratamento ou se o afeto acompanha mais claramente perdas funcionais e eventos de vida.

Autonomia e adesão: A donepezila costuma entrar em rotinas já marcadas por múltiplos cuidados, e a adesão pode depender de cuidador, organização doméstica e aceitação do diagnóstico. Na sessão, esquecimentos sobre uso, respostas vagas sobre horários ou versões divergentes entre paciente e familiar podem sinalizar adesão irregular, o que confunde qualquer leitura sobre resposta clínica. Também vale notar quando o medicamento ganha significado simbólico de esperança, controle ou recusa, porque isso interfere no vínculo com o tratamento e na forma como o paciente relata mudanças.

Carga do cuidado: Frequentemente o impacto mais visível no consultório recai sobre a díade paciente-cuidador: supervisão crescente, discussões sobre segurança, exaustão familiar e redução da privacidade. Isso pode aparecer como interrupções na sessão, respostas dadas pelo acompanhante, tensão na sala ou dificuldade do paciente em sustentar agência própria. Nem toda piora relacional indica piora cognitiva; às vezes reflete sobrecarga do cuidador, luto antecipatório ou rearranjos práticos que se intensificaram após o início do acompanhamento médico."

O que observar em sessão

- **Cognição no setting:** O paciente pode chegar mais lento, mais repetitivo, com dificuldade para sustentar o fio da conversa ou, em alguns casos, discretamente mais acessível e organizado do que na linha de base recente. Na sessão, interessa notar se a oscilação aparece como flutuação ao longo do encontro, se acompanha cansaço, horário da tomada, noites ruins ou intercorrências clínicas, porque isso pode confundir a leitura entre progressão do quadro, efeito inespecífico do tratamento e variação do dia. Mudanças abruptas chamam mais atenção do que diferenças pequenas e estáveis entre sessões.

Sono e vigília: Alterações de sono podem aparecer como sonhos vívidos, fragmentação do sono, sonolência diurna ou maior irritabilidade por noites mal dormidas. No consultório, isso pode se apresentar como menor tolerância à espera, queda de atenção, bocejos frequentes ou dificuldade de elaboração, o que facilmente se confunde com avanço do comprometimento cognitivo ou humor deprimido. Vale comparar com o padrão prévio e com a rotina recente, porque uma piora temporalmente próxima ao início do uso ou a mudanças na adesão pode ter peso clínico diferente de uma insônia crônica já conhecida.

Humor e irritabilidade: Em parte dos pacientes, o que aparece não é uma queixa cognitiva direta, mas mais impaciência, labilidade, retraimento ou desânimo diante das próprias falhas. O terapeuta pode observar aumento de reatividade emocional, vergonha, defensividade ou menor acesso afetivo, mas isso também pode decorrer da consciência do declínio, de conflitos familiares e da experiência de dependência crescente. A tarefa clínica é discriminar se houve mudança de tonalidade afetiva junto com o início do tratamento ou se o afeto acompanha mais claramente perdas funcionais e eventos de vida.

Autonomia e adesão: A donepezila costuma entrar em rotinas já marcadas por múltiplos cuidados, e a adesão pode depender de cuidador, organização doméstica e aceitação do diagnóstico. Na sessão, esquecimentos sobre uso, respostas vagas sobre horários ou versões divergentes entre paciente e familiar podem sinalizar adesão irregular, o que confunde qualquer leitura sobre resposta clínica. Também vale notar quando o medicamento ganha significado simbólico de esperança, controle ou recusa, porque isso interfere no vínculo com o tratamento e na forma como o paciente relata mudanças.

Carga do cuidado: Frequentemente o impacto mais visível no consultório recai sobre a díade paciente-cuidador: supervisão crescente, discussões sobre segurança, exaustão familiar e redução da privacidade. Isso pode aparecer como interrupções na sessão, respostas dadas pelo acompanhante, tensão na sala ou dificuldade do paciente em sustentar agência própria. Nem toda piora relacional indica piora cognitiva; às vezes reflete sobrecarga do cuidador, luto antecipatório ou rearranjos práticos que se intensificaram após o início do acompanhamento médico.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A donepezila é um medicamento usado sobretudo em quadros demenciais, especialmente doença de Alzheimer, e tende a chegar ao consultório mais pelo contexto de declínio cognitivo e cuidado contínuo do que por efeitos subjetivos facilmente nomeáveis. Nas primeiras semanas podem aparecer mudanças no sono, desconforto gastrointestinal, maior cansaço ou agitação, mas o ponto central para o terapeuta costuma ser acompanhar se houve mudança no padrão de atenção, orientação, tolerância à frustração e funcionalidade cotidiana após o início ou após mudanças recentes no tratamento. Em uso contínuo, vale observar flutuações entre sessões, impacto sobre autonomia, sobrecarga do cuidador e consistência da adesão, sem atribuir automaticamente piora ou melhora ao medicamento.

Perguntas úteis

- "O que mudou primeiro desde que você começou a usar esse remédio: seu sono, seu estômago, sua disposição ou sua atenção no dia a dia? , Quando você parece mais confuso ou mais lento, isso costuma acontecer o dia inteiro ou em momentos específicos, como após uma noite ruim, em certos horários ou quando está mais cansado? , Essa irritação ou impaciência que apareceu vem junto com esquecimento e cansaço, ou surge mais em situações de frustração e conflito com outras pessoas? , Nos dias em que a rotina sai do lugar ou alguém esquece de organizar seus remédios, você ou sua família percebem alguma diferença no seu funcionamento? , Quando você diz que está pior, o que exatamente ficou mais difícil: lembrar, se orientar, acompanhar conversa, dormir ou lidar emocionalmente com as limitações?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando há piora cognitiva ou funcional mais abrupta do que o padrão vinha sugerindo
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar progressão esperada de intercorrência clínica ou dificuldade de adesão
- Quando o paciente passa a dormir muito mal
- ter sonhos muito perturbadores ou sonolência diurna que compromete a sessão e a rotina
- pode valer comunicar o médico para revisão da tolerabilidade
- Quando surgem náuseas
- vômitos
- perda de apetite ou recusa persistente do tratamento a ponto de ameaçar a continuidade do uso
- pode valer alinhar com o médico pela chance de abandono silencioso
- Quando paciente e cuidador trazem versões inconsistentes sobre o uso regular ou sobre mudanças recentes no esquema
- pode valer contato com o médico para situar a leitura clínica da resposta observada
- Quando aparece rebaixamento importante do humor
- retraimento acentuado ou irritabilidade nova sem explicação contextual suficiente
- pode valer comunicar o médico para avaliação conjunta do quadro

Vermelho: tratar como urgência

- Confusão acentuada de instalação recente
- com desorientação importante
- rebaixamento do contato habitual ou mudança abrupta do estado mental durante a sessão.: Tratar como intercorrência clínica aguda
- acionar familiar ou cuidador e buscar avaliação médica no mesmo dia; emergência se houver risco imediato
- Desmaio
- quase desmaio
- queda associada a tontura importante ou fraqueza súbita aparece no relato recente ou ocorre no atendimento.: Interromper o foco psicoterápico
- acionar rede de apoio e encaminhar para avaliação médica imediata; emergência se o quadro estiver em curso

Frase clínica

Com donepezila, o foco terapêutico costuma ser menos o fármaco em si e mais as flutuações cognitivas, a adesão e a carga relacional do cuidado.

156 HEMITARTARATO DE RIVASTIGMINA

Substância: Hemitartarato de Rivastigmina.

Nomes Comerciais: Hemitartarato de Rivastigmina, Cogniva, Exelon, Vastigma

Uso comum

- Hemitartarato de rivastigmina é um medicamento usado sobretudo em quadros demenciais, especialmente doença de Alzheimer e, em alguns casos, demência associada à doença de Parkinson. No consultório de terapia, ele costuma aparecer menos como tema central do que como parte de um tratamento contínuo de declínio cognitivo e perda funcional. Nas primeiras semanas após início ou mudanças no uso, podem surgir oscilações de tolerabilidade que repercutem em disposição, apetite, sono e presença na sessão; ao longo de meses, o ponto principal é distinguir flutuação do quadro de base, progressão da doença, intercorrências clínicas e adesão irregular do que parece coincidir com a medicação.

O paciente pode relatar

- **"Cognição cotidiana:** O paciente pode chegar com queixas de memória recente, dificuldade para acompanhar o fio da conversa, maior lentificação ou oscilação de atenção, mas a leitura clínica pede cautela porque esses sinais também acompanham a evolução do quadro neurocognitivo e variam com cansaço, ambiente, dor, infecções e rotina. Na sessão, vale observar se a desorganização é estável, progressiva ou flutuante entre encontros, e se houve mudança temporal próxima ao início do tratamento ou a falhas de uso. Quando a oscilação é muito abrupta para o padrão habitual, a hipótese de intercorrência clínica ganha peso.

Apatia ou sedação: Em parte dos pacientes, pode aparecer mais passividade, redução de iniciativa, menor espontaneidade verbal ou presença mais esmaecida na sessão. Isso pode ser confundido com progressão da demência, humor deprimido, exaustão do cuidador compartilhada no ambiente familiar ou efeito de outras medicações sedativas. A discriminação clínica costuma depender de comparar com a baseline: há perda de interesse subjetivo e sofrimento com isso, ou predomina um rebaixamento inespecífico de energia e responsividade?

Apetite e mal-estar: Náusea, desconforto gastrointestinal, redução do apetite e perda de peso podem repercutir no setting como irritabilidade, menor tolerância à frustração, fadiga e dificuldade de engajamento. Esses elementos às vezes são lidos apenas como piora emocional ou recusa ao tratamento, quando também podem estar ligados a mal-estar corporal persistente. Se o paciente ou a família descrevem piora da alimentação, roupas mais folgadas ou sessões em que ele chega visivelmente mais frágil, vale registrar a temporalidade e o impacto funcional.

Funcionalidade e autonomia: Mudanças em iniciativa para atividades simples, manejo da rotina, necessidade de supervisão e tolerância a tarefas costumam ser mais informativas do que uma impressão global de "estar melhor" ou "estar pior". Na sessão, pode aparecer frustração com perdas, vergonha por depender mais de terceiros ou conflito familiar em torno de autonomia. O que confunde a leitura é que pequenas melhoras ou pioras podem decorrer tanto do contexto ambiental e do suporte recebido quanto do curso da doença e da regularidade do uso do tratamento."

O que observar em sessão

- **Cognição cotidiana:** O paciente pode chegar com queixas de memória recente, dificuldade para acompanhar o fio da conversa, maior lentificação ou oscilação de atenção, mas a leitura clínica pede cautela porque esses sinais também acompanham a evolução do quadro neurocognitivo e variam com cansaço, ambiente, dor, infecções e rotina. Na sessão, vale observar se a desorganização é estável, progressiva ou flutuante entre encontros, e se houve mudança temporal próxima ao início do tratamento ou a falhas de uso. Quando a oscilação é muito abrupta para o padrão habitual, a hipótese de intercorrência clínica ganha peso.

Apatia ou sedação: Em parte dos pacientes, pode aparecer mais passividade, redução de iniciativa, menor espontaneidade verbal ou presença mais esmaecida na sessão. Isso pode ser confundido com progressão da demência, humor deprimido, exaustão do cuidador compartilhada no ambiente familiar ou efeito de outras medicações sedativas. A discriminação clínica costuma depender de comparar com a baseline: há perda de interesse subjetivo e sofrimento com isso, ou predomina um rebaixamento inespecífico de energia e responsividade?

Apetite e mal-estar: Náusea, desconforto gastrointestinal, redução do apetite e perda de peso podem repercutir no setting como irritabilidade, menor tolerância à frustração, fadiga e dificuldade de engajamento. Esses elementos às vezes são lidos apenas como piora emocional ou recusa ao tratamento, quando também podem estar ligados a mal-estar corporal persistente. Se o paciente ou a família descrevem piora da alimentação, roupas mais folgadas ou sessões em que ele chega visivelmente mais frágil, vale registrar a temporalidade e o impacto funcional.

Funcionalidade e autonomia: Mudanças em iniciativa para atividades simples, manejo da rotina, necessidade de supervisão e tolerância a tarefas costumam ser mais informativas do que uma impressão global de “estar melhor” ou “estar pior”. Na sessão, pode aparecer frustração com perdas, vergonha por depender mais de terceiros ou conflito familiar em torno de autonomia. O que confunde a leitura é que pequenas melhoras ou pioras podem decorrer tanto do contexto ambiental e do suporte recebido quanto do curso da doença e da regularidade do uso do tratamento.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Hemitartarato de rivastigmina é um medicamento usado sobretudo em quadros demenciais, especialmente doença de Alzheimer e, em alguns casos, demência associada à doença de Parkinson. No consultório de terapia, ele costuma aparecer menos como tema central do que como parte de um tratamento contínuo de declínio cognitivo e perda funcional. Nas primeiras semanas após início ou mudanças no uso, podem surgir oscilações de tolerabilidade que repercutem em disposição, apetite, sono e presença na sessão; ao longo de meses, o ponto principal é distinguir flutuação do quadro de base, progressão da doença, intercorrências clínicas e adesão irregular do que parece coincidir com a medicação.

Perguntas úteis

- "Quando você sente que está mais confuso ou esquecido, isso fica parecido ao longo do dia ou há momentos em que piora muito de repente? , Essa diminuição de iniciativa vem acompanhada de tristeza e desânimo por dentro, ou você se percebe mais sem energia e menos responsivo, mesmo sem se sentir particularmente triste? , Você notou se o mal-estar no corpo, enjoo ou falta de apetite apareceu junto com alguma mudança recente no tratamento ou já vinha antes desse período? , Nos dias em que você ou sua família percebem piora, isso acontece mesmo mantendo a rotina parecida, ou costuma vir junto de noites ruins, menos alimentação, estresse ou alguma intercorrência física? , Quando você deixa de fazer algo que antes fazia, é porque esquece, porque perde o fio da tarefa, porque fica cansado, ou porque já não vê sentido em começar?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a comer menos
- perde peso de forma perceptível ou chega repetidamente mais debilitado
- pode valer alinhar com o médico assistente para avaliar o impacto clínico dessa piora no tratamento global
- Quando há oscilação cognitiva ou funcional mais abrupta do que a linha de base conhecida
- especialmente em poucos dias
- pode valer comunicar o médico para diferenciar progressão esperada de intercorrência clínica
- Quando a família ou o próprio paciente sugerem uso irregular
- esquecimentos frequentes ou interrupções silenciosas
- pode valer alinhar com o médico assistente porque isso dificulta a leitura do quadro na terapia
- Quando surgem mais apatia
- lentificação ou sonolência e isso compromete de modo novo a participação na sessão e na rotina
- pode valer comunicar o médico para contextualizar a mudança observada
- Quando não se observa qualquer estabilização subjetiva ou funcional após algumas semanas a poucos meses
- apesar de seguimento regular
- pode valer compartilhar a impressão clínica para compor a avaliação longitudinal

Vermelho: tratar como urgência

- Confusão acentuada de instalação rápida
- rebaixamento importante do estado de alerta ou piora súbita do funcionamento em relação ao habitual.: Tratar como possível urgência clínica
- acionar familiar ou cuidador e buscar avaliação médica no mesmo dia; considerar emergência conforme gravidade
- Desmaio

Vermelho: tratar como urgência

- quase desmaio
- queda recente associada a tontura importante ou paciente muito pálido e instável na sessão.: Interromper o trabalho clínico
- garantir segurança imediata e acionar avaliação médica no mesmo dia
- com apoio da rede presente

Frase clínica

O foco clínico é acompanhar flutuação cognitiva e funcional sem confundir progressão do quadro, intercorrências clínicas e uso irregular do tratamento.

157 HIDROGENOTARTARATO DE RIVASTIGMINA

Substância: Hidrogenotartarato de Rivastigmina.

Nomes Comerciais: Vivencia, Hemitartarato de Rivastigmina, Hidrogenotartarato de Rivastigmina

Uso comum

- Hidrogenotartarato de rivastigmina é um medicamento usado sobretudo em quadros demenciais, especialmente quando há queixas de memória, atenção e autonomia no dia a dia. No consultório de terapia, ele tende a aparecer menos como tema central do fármaco e mais como parte do acompanhamento de um paciente com declínio cognitivo progressivo e maior dependência de cuidados. Nas primeiras semanas, podem surgir oscilações de tolerabilidade que repercutem em disposição, apetite e presença na sessão; ao longo de 1 a 3 meses, o ponto de observação costuma ser menos “melhora subjetiva” e mais estabilização relativa, ritmo cognitivo e funcionalidade. Vale acompanhar se mudanças na sessão acompanham a evolução do quadro, intercorrências clínicas ou uso irregular.

O paciente pode relatar

- **"Cognição na sessão:** O terapeuta pode notar variação em atenção sustentada, velocidade de processamento, capacidade de acompanhar o fio da conversa e recordar conteúdos entre sessões. Nem toda oscilação sugere mudança ligada ao medicamento: infecções, noites ruins, dor, sobrecarga ambiental e a própria progressão do quadro podem produzir um padrão semelhante. Ajuda comparar com a linha de base recente e observar se a flutuação é episódica, ligada a horários específicos ou se vem se consolidando ao longo de semanas.

Funcionalidade: Mudanças em autonomia para tarefas simples, organização da rotina e necessidade de apoio de familiares costumam ter mais peso clínico do que uma impressão global de “estar melhor” ou “pior”. Às vezes o paciente chega mais dependente, mais confuso com compromissos ou menos capaz de sustentar combinados terapêuticos, mas isso também pode refletir eventos de vida, hospitalizações, luto ou descompensação clínica geral. Na sessão, vale observar se a perda funcional é gradual, se houve queda mais abrupta ou se há discrepância entre o que o paciente relata e o que a família descreve.

Humor e reatividade: Acompanhando quadros demenciais, podem aparecer apatia, irritabilidade, labilidade emocional ou retraimento, que facilmente se confundem com depressão, frustração diante das perdas ou efeito inespecífico de mal-estar físico. Em alguns encontros, o paciente parece menos engajado não por piora afetiva primária, mas por fadiga, náusea, desconforto corporal ou maior esforço cognitivo para sustentar a conversa. O ponto clínico é diferenciar redução de iniciativa, sofrimento psíquico elaborável e reatividade a limitações crescentes.

Tolerabilidade inicial: Nas primeiras semanas, indisposição, náusea, redução do apetite ou mal-estar podem aparecer no relato e alterar a qualidade da presença em sessão. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinteresse pelo processo ou agravamento cognitivo, quando às vezes o paciente está simplesmente menos disponível por desconforto físico. Se o padrão coincide com início recente, retomada após interrupção ou uso irregular, essa hipótese ganha força observacional, sem excluir outras causas clínicas.

Carga do cuidado: Frequentemente o impacto mais visível em terapia recai sobre a rede de cuidado: familiares mais vigilantes, conflitos sobre supervisão, vergonha pela perda de autonomia e tensão em torno de esquecimentos e riscos domésticos. O paciente pode oscilar entre minimizar dificuldades e sentir-se invadido, enquanto cuidadores chegam exaustos ou controladores. Nessa medicação, muitas vezes o trabalho terapêutico se organiza menos em torno do remédio em si e mais em torno de adaptação à doença, preservação de dignidade e manejo do vínculo em contexto de dependência crescente."

O que observar em sessão

- **Cognição na sessão:** O terapeuta pode notar variação em atenção sustentada, velocidade de processamento, capacidade de acompanhar o fio da conversa e recordar conteúdos entre sessões. Nem toda oscilação sugere mudança ligada ao medicamento: infecções, noites ruins, dor, sobrecarga ambiental e a própria progressão do quadro podem produzir um padrão semelhante. Ajuda comparar com a linha de base recente e observar se a flutuação é episódica, ligada a horários específicos ou se vem se consolidando ao longo de semanas.

Funcionalidade: Mudanças em autonomia para tarefas simples, organização da rotina e necessidade de apoio de familiares costumam ter mais peso clínico do que uma impressão global de “estar melhor” ou “pior”. Às vezes o paciente chega mais dependente, mais confuso com compromissos ou menos capaz de sustentar combinados terapêuticos, mas isso também pode refletir eventos de vida, hospitalizações, luto ou descompensação clínica geral. Na sessão, vale observar se a perda funcional é gradual, se houve queda mais abrupta ou se há discrepância entre o que o paciente relata e o que a família descreve.

Humor e reatividade: Acompanhando quadros demenciais, podem aparecer apatia, irritabilidade, labilidade emocional ou retraimento, que facilmente se confundem com depressão, frustração diante das perdas ou efeito inespecífico de mal-estar físico. Em alguns encontros, o paciente parece menos engajado não por piora afetiva primária, mas por fadiga, náusea, desconforto corporal ou maior esforço cognitivo para sustentar a conversa. O ponto clínico é diferenciar redução de iniciativa, sofrimento psíquico elaborável e reatividade a limitações crescentes.

Tolerabilidade inicial: Nas primeiras semanas, indisposição, náusea, redução do apetite ou mal-estar podem aparecer no relato e alterar a qualidade da presença em sessão. Isso pode ser lido apressadamente como piora depressiva, desinteresse pelo processo ou agravamento cognitivo, quando às vezes o paciente está simplesmente menos disponível por desconforto físico. Se o padrão coincide com início recente, retomada após interrupção ou uso irregular, essa hipótese ganha força observacional, sem excluir outras causas clínicas.

Carga do cuidado: Frequentemente o impacto mais visível em terapia recai sobre a rede de cuidado: familiares mais vigilantes, conflitos sobre supervisão, vergonha pela perda de autonomia e tensão em torno de esquecimentos e riscos domésticos. O paciente pode oscilar entre minimizar dificuldades e sentir-se invadido, enquanto cuidadores chegam exaustos ou controladores. Nessa medicação, muitas vezes o trabalho terapêutico se organiza menos em torno do remédio em si e mais em torno de adaptação à doença, preservação de dignidade e manejo do vínculo em contexto de dependência crescente.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Hidrogenotartarato de rivastigmina é um medicamento usado sobretudo em quadros demenciais, especialmente quando há queixas de memória, atenção e autonomia no dia a dia. No consultório de terapia, ele tende a aparecer menos como tema central do fármaco e mais como parte do acompanhamento de um paciente com declínio cognitivo progressivo e maior dependência de cuidados. Nas primeiras semanas, podem surgir oscilações de tolerabilidade que repercutem em disposição, apetite e presença na sessão; ao longo de 1 a 3 meses, o ponto de observação costuma ser menos “melhora subjetiva” e mais estabilização relativa, ritmo cognitivo e funcionalidade. Vale acompanhar se mudanças na sessão acompanham a evolução do quadro, intercorrências clínicas ou uso irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você esquece algo ou se perde no assunto, isso acontece de modo parecido ao longo do dia ou há momentos em que fica claramente pior? , Nas últimas semanas, o que mais mudou foi sua memória e organização, ou sua disposição para fazer as coisas mesmo quando sabe o que precisa fazer? , Esse desânimo ou afastamento vem junto com tristeza e sofrimento reconhecíveis, ou parece mais um cansaço/indisposição que dificulta até conversar? , As dificuldades do dia a dia têm aumentado aos poucos ou houve uma mudança mais brusca depois de alguma intercorrência, doença ou alteração na rotina? , Quando você falta, chega mais abatido ou evita atividades, isso costuma vir acompanhado de enjoo, perda de apetite ou outro mal-estar físico? , O que sua família percebe como piora combina com o que você próprio nota, ou há uma diferença importante entre essas duas leituras?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente apresenta piora cognitiva ou funcional mais abrupta do que o padrão das semanas anteriores
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar progressão esperada de intercorrência clínica ou dificuldade de tolerabilidade
- Quando náusea
- perda de apetite
- indisposição ou recusa alimentar começam a comprometer presença em sessão
- rotina ou adesão
- pode valer comunicar o médico para revisão do impacto clínico dessas queixas
- Quando a família descreve uso irregular
- esquecimentos frequentes ou interrupções silenciosas
- pode valer alinhar com o médico porque isso dificulta a leitura da evolução do quadro
- Quando surgem agitação
- confusão ou rebaixamento do funcionamento muito diferentes da linha de base
- pode valer contato com o médico para avaliar se há condição clínica associada além da evolução cognitiva

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o trabalho terapêutico passa a depender fortemente de cuidadores por perda de autonomia e segurança no cotidiano
- pode valer comunicação para alinhamento do momento clínico e das limitações atuais

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão aparece confusão aguda
- importante desorientação ou rebaixamento claro em relação ao padrão habitual
- especialmente se de início recente.: Tratar como possível intercorrência clínica aguda
- acionar médico e rede de apoio no mesmo dia e considerar avaliação de urgência conforme o contexto
- Há recusa alimentar relevante
- vômitos repetidos ou fraqueza acentuada com impacto evidente no estado geral.: Interromper o foco psicoterápico
- acionar familiar ou cuidador e buscar avaliação médica no mesmo dia

Frase clínica

O foco clínico costuma ser menos o fármaco em si e mais como cognição, funcionalidade e rede de cuidado se reorganizam ao longo do acompanhamento.

158 RIVASTIGMINA

Substância: Rivastigmina.

Nomes Comerciais: Rivastigmina, Vivencia Patch

Uso comum

- Rivastigmina é um medicamento usado sobretudo em quadros demenciais, com mais frequência doença de Alzheimer e, em alguns casos, demência associada à doença de Parkinson. No consultório de terapia, ela costuma aparecer menos como tema central do fármaco e mais como parte de um tratamento contínuo em que o paciente e a família tentam sustentar rotina, autonomia e vínculo. Nas primeiras semanas após início ou mudança recente no esquema, vale observar se houve alteração perceptível de atenção, tolerância corporal, apetite ou disposição; ao longo de meses, o foco tende a ser menos “efeito” e mais trajetória funcional, oscilação cognitiva e impacto subjetivo da progressão do quadro.

O paciente pode relatar

- **"Cognição cotidiana:** Na sessão, podem aparecer esquecimentos mais evidentes, dificuldade para acompanhar o fio da conversa, repetição de temas ou maior lentificação para organizar respostas. Isso pode ser lido apressadamente como piora linear do quadro, quando às vezes oscila com horário do dia, cansaço, ambiente, intercorrências clínicas ou adesão irregular. O ponto útil para o terapeuta é comparar com a própria linha de base recente do paciente e com a funcionalidade narrada pela família, sem tomar uma sessão isolada como medida suficiente.

Tolerabilidade inicial: Em parte dos pacientes, as primeiras semanas podem vir acompanhadas de mal-estar corporal, náusea, redução do apetite, indisposição ou maior retraimento, o que na sessão pode se confundir com apatia depressiva ou desinvestimento no processo terapêutico. Quando isso surge perto do início do tratamento ou de mudança recente no uso, vale registrar a coincidência temporal sem concluir causalidade. Se o paciente passa a faltar, encurtar a sessão ou evitar atividades habituais, a hipótese de desconforto físico silencioso entra no radar.

Humor e apatia: O paciente pode parecer mais apagado, com menor iniciativa, menos elaboração espontânea e acesso afetivo reduzido, mas esse padrão nem sempre distingue sozinho depressão, progressão cognitiva, fadiga física ou efeito inespecífico do tratamento global. Também pode haver momentos em que a família percebe "está mais calmo", enquanto o paciente parece apenas menos responsivo. Na sessão, ajuda observar se houve perda de interesse subjetivamente sofrida ou apenas redução da expressividade, porque isso muda a leitura clínica e a necessidade de comunicação.

Autonomia e identidade: À medida que o tratamento se prolonga, o tema central frequentemente deixa de ser o medicamento e passa a ser a experiência de depender mais de lembretes, supervisão e ajuda prática. Isso pode emergir como vergonha, irritação, defensividade ou minimização das dificuldades, especialmente quando o paciente ainda preserva crítica parcial. O terapeuta precisa discriminar o que é sofrimento pela perda de autonomia do que é conflito familiar em torno de controle, já que ambos podem aparecer como "resistência" na sessão.

Adesão e manejo familiar: Com rivastigmina, a adesão pode ficar menos transparente quando o paciente depende de cuidador, esquece tomadas ou não sabe descrever com precisão como está usando o tratamento. Na sessão, isso aparece como narrativa vaga, versões divergentes entre paciente e familiar, ou oscilação funcional sem explicação clara. Antes de atribuir mudança clínica ao medicamento ou à doença, vale mapear quem organiza o uso, se houve falhas recentes e se o tema virou foco de tensão doméstica."

O que observar em sessão

- **Cognição cotidiana:** Na sessão, podem aparecer esquecimentos mais evidentes, dificuldade para acompanhar o fio da conversa, repetição de temas ou maior lentificação para organizar respostas. Isso pode ser lido apressadamente como piora linear do quadro, quando às vezes oscila com horário do dia, cansaço, ambiente, intercorrências clínicas ou adesão irregular. O ponto útil para o terapeuta é comparar com a própria linha de base recente do paciente e com a funcionalidade narrada pela família, sem tomar uma sessão isolada como medida suficiente.

Tolerabilidade inicial: Em parte dos pacientes, as primeiras semanas podem vir acompanhadas de mal-estar corporal, náusea, redução do apetite, indisposição ou maior retraimento, o que na sessão pode se confundir com apatia depressiva ou desinvestimento no processo terapêutico. Quando isso surge perto do início do tratamento ou de mudança recente no uso, vale registrar a coincidência temporal sem concluir causalidade. Se o paciente passa a faltar, encurtar a sessão ou evitar atividades habituais, a hipótese de desconforto físico silencioso entra no radar.

Humor e apatia: O paciente pode parecer mais apagado, com menor iniciativa, menos elaboração espontânea e acesso afetivo reduzido, mas esse padrão nem sempre distingue sozinho depressão, progressão cognitiva, fadiga física ou efeito inespecífico do tratamento global. Também pode haver momentos em que a família percebe “está mais calmo”, enquanto o paciente parece apenas menos responsivo. Na sessão, ajuda observar se houve perda de interesse subjetivamente sofrida ou apenas redução da expressividade, porque isso muda a leitura clínica e a necessidade de comunicação.

Autonomia e identidade: À medida que o tratamento se prolonga, o tema central frequentemente deixa de ser o medicamento e passa a ser a experiência de depender mais de lembretes, supervisão e ajuda prática. Isso pode emergir como vergonha, irritação, defensividade ou minimização das dificuldades, especialmente quando o paciente ainda preserva crítica parcial. O terapeuta precisa discriminar o que é sofrimento pela perda de autonomia do que é conflito familiar em torno de controle, já que ambos podem aparecer como “resistência” na sessão.

Adesão e manejo familiar: Com rivastigmina, a adesão pode ficar menos transparente quando o paciente depende de cuidador, esquece tomadas ou não sabe descrever com precisão como está usando o tratamento. Na sessão, isso aparece como narrativa vaga, versões divergentes entre paciente e familiar, ou oscilação funcional sem explicação clara. Antes de atribuir mudança clínica ao medicamento ou à doença, vale mapear quem organiza o uso, se houve falhas recentes e se o tema virou foco de tensão doméstica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Rivastigmina é um medicamento usado sobretudo em quadros demenciais, com mais frequência doença de Alzheimer e, em alguns casos, demência associada à doença de Parkinson. No consultório de terapia, ela costuma aparecer menos como tema central do fármaco e mais como parte de um tratamento contínuo em que o paciente e a família tentam sustentar rotina, autonomia e vínculo. Nas primeiras semanas após início ou mudança recente no esquema, vale observar se houve alteração perceptível de atenção, tolerância corporal, apetite ou disposição; ao longo de meses, o foco tende a ser menos “efeito” e mais trajetória funcional, oscilação cognitiva e impacto subjetivo da progressão do quadro.

Perguntas úteis

- "Essas falhas de memória e atenção têm parecido constantes ao longo da semana ou variam bastante conforme horário, cansaço ou contexto? , Quando você se sente mais apagado ou sem iniciativa, isso vem junto de tristeza e sofrimento por estar assim, ou parece mais uma dificuldade de engatar e sustentar as coisas? , Essa piora que você ou a família notaram começou de forma gradual ou apareceu mais de repente nos últimos dias? , Quem tem acompanhado o uso do remédio no dia a dia, e nas últimas semanas houve esquecimentos, recusas ou confusão com a rotina? , Quando você fica mais quieto na sessão, sente que está sem vontade de falar ou que está mais difícil encontrar as palavras e acompanhar a conversa?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando há piora cognitiva ou funcional mais abrupta do que o padrão habitual
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar progressão esperada de intercorrência clínica ou problema no uso
- Quando náusea
- perda de apetite
- indisposição ou retraimento passam a comprometer alimentação
- presença em sessão ou rotina básica
- pode valer comunicar para revisão da tolerabilidade
- Quando paciente e familiar trazem versões muito discrepantes sobre adesão
- ou o uso depende de terceiros e parece irregular
- pode valer alinhar com o médico para contextualizar a leitura da resposta clínica
- Quando surgem apatia importante
- queda de iniciativa ou rebaixamento do engajamento que não se explicam bem pela linha de base recente
- pode valer comunicar para avaliação conjunta do quadro
- Quando há alucinações
- confusão mais intensa ou mudança comportamental relevante em paciente com demência associada à doença de Parkinson
- pode valer contato com o médico pela mudança do padrão clínico

Vermelho: tratar como urgência

- Surge confusão aguda
- desorientação importante
- rebaixamento acentuado do estado geral ou incapacidade súbita de se manter minimamente organizado na sessão.: Tratar como mudança clínica do dia
- acionar familiar ou cuidador e buscar avaliação médica no mesmo dia; considerar emergência conforme gravidade
- Aparecem ideias de morte
- desesperança intensa ou fala suicida em paciente com demência
- especialmente se houver agitação
- impulsividade ou supervisão frágil.: Fazer manejo de risco imediato
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia; recorrer à emergência quando a segurança estiver comprometida

Frase clínica

Com rivastigmina, o foco terapêutico costuma ser menos o fármaco em si e mais a oscilação cognitiva, a autonomia e o manejo familiar do tratamento.

159 CLORIDRATO DE MEMANTINA

Substância: Cloridrato de Memantina.

Nomes Comerciais: Zider, Heimer, Cloridrato de Memantina, Alois, Moriale Odt, Alz, Desirée, Ebix, Mealz, Vie, Kamppi, Maizher

Uso comum

- A memantina é um fármaco usado sobretudo em quadros neurocognitivos, especialmente doença de Alzheimer em fases moderadas a graves, e às vezes aparece no consultório quando o paciente ainda consegue participar da psicoterapia ou quando a família informa o uso. Nas primeiras semanas, podem surgir mudanças discretas em clareza mental, tolerância à frustração, sonolência, tontura ou maior lentificação, mas a leitura clínica costuma ser difícil porque o próprio quadro de base evolui ao longo de semanas e meses. O ponto central na sessão é menos atribuir efeito ao medicamento e mais acompanhar variações de atenção, orientação, funcionalidade e sustentação do vínculo terapêutico em relação à baseline recente.

O paciente pode relatar

- **"Cognição na sessão:** O paciente pode oscilar entre momentos de maior presença e trechos de confusão, lentificação ou dificuldade para sustentar o fio da conversa. Na sessão, vale observar se há mudança em atenção, evocação de fatos recentes, compreensão de perguntas simples e capacidade de acompanhar a tarefa terapêutica em comparação com encontros anteriores. Isso pode se confundir tanto com progressão do quadro neurocognitivo quanto com fadiga, infecções intercorrentes, privação de sono, ambiente novo ou uso irregular da medicação.

Tontura e lentificação: Alguns pacientes ficam mais vagarosos, sonolentos ou inseguros corporalmente, o que pode aparecer como fala mais pausada, necessidade de repetir perguntas ou receio ao levantar-se e caminhar. Em consultório, isso pode ser lido apressadamente como apatia depressiva ou desinvestimento, quando às vezes se trata de alteração física ou cognitiva transitória. Também é um campo sujeito a confusão com envelhecimento, outras medicações sedativas, hipotensão, dor, desidratação e piora clínica global.

Humor e irritabilidade: Mudanças de humor costumam aparecer de forma pouco específica: mais irritabilidade, menor tolerância a frustração, retraimento ou, em alguns casos, aparente alívio por estar menos confuso em certos momentos. O terapeuta pode notar reatividade emocional diferente da baseline, mas precisa situá-la no contexto de perdas funcionais, dependência crescente, conflitos familiares e consciência variável do próprio declínio. Atribuir essas mudanças apenas ao medicamento tende a simplificar demais um quadro em que doença de base e eventos de vida pesam muito.

Funcionalidade cotidiana: A pista clínica mais útil muitas vezes vem do cotidiano: conseguir seguir uma rotina simples, localizar objetos, manter pequenas conversas, participar de atividades conhecidas ou tolerar melhor cuidados diários. Na sessão, vale comparar o que o paciente e os cuidadores descrevem como capacidade habitual nas últimas semanas, em vez de se apoiar apenas no desempenho daquele dia. Oscilações pontuais podem refletir adesão irregular, intercorrências clínicas, sobrecarga ambiental ou progressão do transtorno neurocognitivo."

O que observar em sessão

- **Cognição na sessão:** O paciente pode oscilar entre momentos de maior presença e trechos de confusão, lentificação ou dificuldade para sustentar o fio da conversa. Na sessão, vale observar se há mudança em atenção, evocação de fatos recentes, compreensão de perguntas simples e capacidade de acompanhar a tarefa terapêutica em comparação com encontros anteriores. Isso pode se confundir tanto com progressão do quadro neurocognitivo quanto com fadiga, infecções intercorrentes, privação de sono, ambiente novo ou uso irregular da medicação.

Tontura e lentificação: Alguns pacientes ficam mais vagarosos, sonolentos ou inseguros corporalmente, o que pode aparecer como fala mais pausada, necessidade de repetir perguntas ou receio ao levantar-se e caminhar. Em consultório, isso pode ser lido apressadamente como apatia depressiva ou desinvestimento, quando às vezes se trata de alteração física ou cognitiva transitória. Também é um campo sujeito a confusão com envelhecimento, outras medicações sedativas, hipotensão, dor, desidratação e piora clínica global.

Humor e irritabilidade: Mudanças de humor costumam aparecer de forma pouco específica: mais irritabilidade, menor tolerância a frustração, retraimento ou, em alguns casos, aparente alívio por estar menos confuso em certos momentos. O terapeuta pode notar reatividade emocional diferente da baseline, mas precisa situá-la no contexto de perdas funcionais, dependência crescente, conflitos familiares e consciência variável do próprio declínio. Atribuir essas mudanças apenas ao medicamento tende a simplificar demais um quadro em que doença de base e eventos de vida pesam muito.

Funcionalidade cotidiana: A pista clínica mais útil muitas vezes vem do cotidiano: conseguir seguir uma rotina simples, localizar objetos, manter pequenas conversas, participar de atividades conhecidas ou tolerar melhor cuidados diários. Na sessão, vale comparar o que o paciente e os cuidadores descrevem como capacidade habitual nas últimas semanas, em vez de se apoiar apenas no desempenho daquele dia. Oscilações pontuais podem refletir adesão irregular, intercorrências clínicas, sobrecarga ambiental ou progressão do transtorno neurocognitivo.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A memantina é um fármaco usado sobretudo em quadros neurocognitivos, especialmente doença de Alzheimer em fases moderadas a graves, e às vezes aparece no consultório quando o paciente ainda consegue participar da psicoterapia ou quando a família informa o uso. Nas primeiras semanas, podem surgir mudanças discretas em clareza mental, tolerância à frustração, sonolência, tontura ou maior lentificação, mas a leitura clínica costuma ser difícil porque o próprio quadro de base evolui ao longo de semanas e meses. O ponto central na sessão é menos atribuir efeito ao medicamento e mais acompanhar variações de atenção, orientação, funcionalidade e sustentação do vínculo terapêutico em relação à baseline recente.

Perguntas úteis

- "Essa dificuldade para acompanhar a conversa está parecida com o seu padrão das últimas semanas ou hoje parece um dia fora do habitual? , Quando você fica mais lento ou confuso, isso acontece o dia todo ou aparece em momentos específicos, como após tomar remédios, ao acordar ou no fim do dia? , Nessas últimas semanas, você percebeu mais esquecimento e desorientação em várias situações do cotidiano ou mais cansaço e sonolência sem tanta piora da memória? , Quando a irritação aparece, ela vem junto com sensação de confusão e sobrecarga ou parece mais ligada a conflitos, frustrações e acontecimentos do dia? , Você tem conseguido manter as mesmas pequenas tarefas e conversas de antes, ou houve uma mudança mais nítida na sua autonomia recente?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar muito mais confuso
- desorientado ou incapaz de sustentar a conversa em comparação com a baseline recente
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar progressão do quadro
- intercorrência clínica e possível relação temporal com o tratamento
- Quando surgem tontura
- instabilidade ao andar ou sonolência que começam a comprometer segurança
- participação na sessão ou rotina básica
- pode valer comunicar o médico para revisão clínica do quadro geral
- Quando familiares ou cuidadores descrevem oscilação importante entre dias de uso e dias sem uso
- ou abandono silencioso por dificuldade prática
- pode valer alinhar com o médico assistente porque a leitura da evolução fica pouco confiável
- Quando não se observa qualquer ganho funcional ou há piora consistente após algumas semanas a poucos meses de acompanhamento
- pode valer comunicar o médico para situar a evolução clínica com base em exemplos concretos do cotidiano e da sessão

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente apresenta rebaixamento importante do nível de consciência
- não consegue se manter desperto ou parece subitamente muito mais confuso do que o habitual.: Interromper o trabalho psicoterápico
- acionar familiar ou cuidador e buscar avaliação médica no mesmo dia; considerar emergência conforme o grau de comprometimento
- Surge confusão aguda acompanhada de queda
- incapacidade de se orientar minimamente ou mudança abrupta de comportamento que foge muito do padrão conhecido.: Tratar como alteração clínica aguda

Vermelho: tratar como urgência

- acionar rede de apoio imediatamente e encaminhar para avaliação médica urgente

Frase clínica

Com memantina, o foco terapêutico é acompanhar variações de cognição e funcionalidade sem confundir efeito do tratamento com evolução do quadro de base.

160 CLORIDRATO DE MEMANTINA; CLORIDRATO DE DONEPEZILA

Substância: Cloridrato de Memantina; Cloridrato de Donepezila.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Donepezila + Cloridrato de Memantina, Alois Duo, Alois Duo Pack, Moriale Duo, Comfect Duo, Donila Duo

Uso comum

- A combinação donepezila + memantina costuma aparecer no consultório em pacientes com quadros demenciais, sobretudo quando já há impacto cognitivo e funcional mais evidente. Para o terapeuta, o foco não é esperar uma mudança subjetiva rápida, mas acompanhar ao longo de semanas a poucos meses se há estabilização, pequenas oscilações ou progressão do quadro, sempre comparando com a linha de base recente. No início ou após mudanças no esquema prescritas pelo médico, podem surgir mais confusão, sonolência, náusea, irritabilidade ou piora transitória do engajamento. Em uso contínuo, a questão central em sessão é diferenciar efeito do tratamento, avanço da doença, intercorrências clínicas e adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Cognição cotidiana:** Na sessão, podem aparecer esquecimentos mais salientes, perda do fio da conversa, repetição de perguntas, dificuldade para nomear fatos recentes ou maior dependência do acompanhante para reconstruir a semana. Isso nem sempre indica piora linear: o desempenho pode oscilar conforme horário, fadiga, ambiente, ansiedade e presença de infecções ou outras intercorrências clínicas. Vale comparar com a linha de base das últimas semanas e observar se a oscilação é episódica ou se há um rebaixamento mais consistente do funcionamento.

Engajamento na sessão: Alguns pacientes chegam mais lentificados, sonolentos ou com menor iniciativa verbal, enquanto outros mantêm contato suficiente, mas com acesso afetivo mais empobrecido e menor capacidade de elaboração. Esse padrão pode ser confundido com depressão, apatia do quadro neurocognitivo, privação de sono ou efeito de outras medicações sedativas em uso concomitante. A observação clínica ganha valor quando se nota mudança nítida em relação ao estilo habitual de presença, responsividade e tolerância ao esforço cognitivo da sessão.

Humor e irritabilidade: Irritabilidade, frustração diante de falhas cognitivas, labilidade emocional ou retraimento podem aparecer no curso do tratamento, mas frequentemente se misturam ao impacto subjetivo da perda funcional e às reações familiares ao adoecimento. Em parte dos casos, o paciente parece mais reativo em contextos de exigência cognitiva, o que pode ser lido apressadamente como piora psiquiátrica primária. Ajuda discriminar se a alteração de humor acompanha situações de confusão e sobrecarga ou se surge de modo mais difuso, persistente e pouco contextual.

Autonomia e rotina: Mudanças na capacidade de manejar compromissos, medicação, finanças, higiene ou deslocamentos costumam aparecer antes como falhas na rotina do que como queixa cognitiva direta. Na terapia, isso pode surgir como aumento da dependência do cuidador, faltas, atrasos, desencontro de informações ou dificuldade para sustentar combinados simples. Nem sempre se trata de progressão do quadro: adesão irregular, desorganização ambiental, sobrecarga familiar e eventos médicos recentes também podem explicar uma queda funcional aparentemente abrupta.

Adesão e suporte: Com essa combinação, a adesão muitas vezes depende menos de intenção e mais de supervisão concreta, organização doméstica e clareza da rede de cuidado. Quando o paciente não sabe nomear o que toma, alterna versões da rotina ou chega com relatos incompatíveis entre si, vale considerar esquecimento, recusa silenciosa, confusão entre caixas ou manejo inconsistente por cuidadores. Esse ponto é clinicamente relevante porque oscilações atribuídas ao quadro podem refletir uso irregular, sem que o paciente consiga descrevê-lo com precisão."

O que observar em sessão

- **Cognição cotidiana:** Na sessão, podem aparecer esquecimentos mais salientes, perda do fio da conversa, repetição de perguntas, dificuldade para nomear fatos recentes ou maior dependência do acompanhante para reconstruir a semana. Isso nem sempre indica piora linear: o desempenho pode oscilar conforme horário, fadiga, ambiente, ansiedade e presença de infecções ou outras intercorrências clínicas. Vale comparar com a linha de base das últimas semanas e observar se a oscilação é episódica ou se há um rebaixamento mais consistente do funcionamento.

Engajamento na sessão: Alguns pacientes chegam mais lentificados, sonolentos ou com menor iniciativa verbal, enquanto outros mantêm contato suficiente, mas com acesso afetivo mais empobrecido e menor capacidade de elaboração. Esse padrão pode ser confundido com depressão, apatia do quadro neurocognitivo, privação de sono ou efeito de outras medicações sedativas em uso concomitante. A observação clínica ganha valor quando se nota mudança nítida em relação ao estilo habitual de presença, responsividade e tolerância ao esforço cognitivo da sessão.

Humor e irritabilidade: Irritabilidade, frustração diante de falhas cognitivas, labilidade emocional ou retraimento podem aparecer no curso do tratamento, mas frequentemente se misturam ao impacto subjetivo da perda funcional e às reações familiares ao adoecimento. Em parte dos casos, o paciente parece mais reativo em contextos de exigência cognitiva, o que pode ser lido apressadamente como piora psiquiátrica primária. Ajuda discriminar se a alteração de humor acompanha situações de confusão e sobrecarga ou se surge de modo mais difuso, persistente e pouco contextual.

Autonomia e rotina: Mudanças na capacidade de manejar compromissos, medicação, finanças, higiene ou deslocamentos costumam aparecer antes como falhas na rotina do que como queixa cognitiva direta. Na terapia, isso pode surgir como aumento da dependência do cuidador, faltas, atrasos, desencontro de informações ou dificuldade para sustentar combinados simples. Nem sempre se trata de progressão do quadro: adesão irregular, desorganização ambiental, sobrecarga familiar e eventos médicos recentes também podem explicar uma queda funcional aparentemente abrupta.

Adesão e suporte: Com essa combinação, a adesão muitas vezes depende menos de intenção e mais de supervisão concreta, organização doméstica e clareza da rede de cuidado. Quando o paciente não sabe nomear o que toma, alterna versões da rotina ou chega com relatos incompatíveis entre si, vale considerar esquecimento, recusa silenciosa, confusão entre caixas ou manejo inconsistente por cuidadores. Esse ponto é clinicamente relevante porque oscilações atribuídas ao quadro podem refletir uso irregular, sem que o paciente consiga descrevê-lo com precisão.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A combinação donepezila + memantina costuma aparecer no consultório em pacientes com quadros demenciais, sobretudo quando já há impacto cognitivo e funcional mais evidente. Para o terapeuta, o foco não é esperar uma mudança subjetiva rápida, mas acompanhar ao longo de semanas a poucos meses se há estabilização, pequenas oscilações ou progressão do quadro, sempre comparando com a linha de base recente. No início ou após mudanças no esquema prescritas pelo médico, podem surgir mais confusão, sonolência, náusea, irritabilidade ou piora transitória do engajamento. Em uso contínuo, a questão central em sessão é diferenciar efeito do tratamento, avanço da doença, intercorrências clínicas e adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe dias piores, isso costuma acontecer em certos horários ou aparece de forma parecida o dia todo? , Nas últimas semanas, você sente que esquece porque as coisas somem da cabeça ou porque fica cansado, sonolento ou confuso durante a conversa? , Quando você fica mais irritado ou retraído, isso vem depois de situações em que se sente cobrado ou perdido, ou aparece mesmo em momentos tranquilos? , Quem costuma organizar seus remédios e sua rotina em casa, e o que acontece nos dias em que essa ajuda falha? , Comparando com um ou dois meses atrás, o que mudou mais: sua memória, sua disposição para conversar ou sua capacidade de tocar a rotina?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando há queda funcional mais rápida do que a linha de base recente sugeria
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar progressão do quadro
- intercorrência clínica e uso irregular
- Quando o paciente ou cuidador descreve sonolência
- confusão ou piora do engajamento logo após início do tratamento ou mudança recente no esquema prescrito
- pode valer comunicar para revisão clínica da tolerabilidade
- Quando surgem versões muito inconsistentes sobre tomada da medicação
- faltas frequentes ou sinais de que a supervisão doméstica falhou
- pode valer contato com o médico para situar a adesão real
- Quando irritabilidade
- agitação ou retraimento aumentam junto com piora cognitiva ou desorganização da rotina
- pode valer alinhar com o médico para avaliar se há intercorrência clínica além do curso esperado do quadro

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- há rebaixamento importante do nível de alerta

Vermelho: tratar como urgência

- desorientação acentuada ou incapacidade súbita de sustentar contato mínimo
- sobretudo se isso representa mudança aguda.: Interromper o trabalho habitual
- acionar familiar ou cuidador e buscar avaliação médica no mesmo dia
- considerando emergência se não houver retaguarda segura
- Aparecem ideias de morte
- desesperança intensa ou comportamento autoagressivo em paciente com sofrimento marcado pela perda cognitiva e funcional.: Fazer manejo de risco na hora
- acionar rede de apoio e médico assistente imediatamente
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

O foco clínico é distinguir oscilação cognitiva e funcional do curso do quadro, da adesão irregular e de intercorrências clínicas.

161 CLORIDRATO DE MEMANTINA; CLORIDRATO DE DONEPEZILA MONOIDRATADO

Substância: Cloridrato de Memantina; Cloridrato de Donepezila Monoidratado.

Nomes Comerciais: Lábrea Duo, Epéz Duo, Cloridrato de Donepezila + Cloridrato de Memantina

Uso comum

- Associação usada sobretudo em quadros neurocognitivos, em especial demência de Alzheimer em fases moderadas a mais avançadas. No consultório, o foco raramente é “efeito do remédio” isolado: importa acompanhar se, ao longo de semanas a poucos meses, há estabilização, piora progressiva ou flutuação do funcionamento, e como isso repercute em autonomia, vínculo e tolerância ao cuidado. Mudanças abruptas tendem a pedir leitura cautelosa, porque podem refletir intercorrências clínicas, adesão irregular, sobrecarga do cuidador ou progressão do quadro de base. A sessão costuma girar em torno de cognição prática, ritmo, apetite, sono e sustentação do trabalho terapêutico.

O paciente pode relatar

- **"Cognição prática:** Na sessão, podem aparecer esquecimentos mais evidentes, repetição de perguntas, perda do fio da conversa e dificuldade para acompanhar combinações simples. O ponto clínico é distinguir declínio progressivo esperado do quadro de base de uma mudança mais brusca no padrão habitual, que pode sugerir intercorrência clínica, oscilação do uso ou desorganização ambiental. Vale comparar com a linha de base recente: o paciente está parecido com as últimas semanas ou houve uma inflexão nítida?.

Ritmo e vigília: Alguns pacientes chegam mais lentificados, sonolentos ou com menor iniciativa, enquanto outros oscilam bastante ao longo do dia. Isso pode ser confundido com apatia do quadro neurocognitivo, depressão, noites mal dormidas ou rotina de cuidados desorganizada. Na observação clínica, ajuda notar se a queda de presença mental é constante na sessão ou se varia conforme horário, contexto e qualidade do sono relatada.

Humor e irritabilidade: Irritabilidade, impaciência, retraimento ou maior labilidade emocional podem aparecer mais como mudança de manejo afetivo do que como queixa espontânea. Nem sempre isso aponta para efeito da medicação; frustração diante das perdas cognitivas, conflitos com cuidadores e sensação de dependência costumam pesar bastante. O terapeuta ganha precisão quando observa se a alteração afetiva acompanha piora funcional global, eventos de vida ou mudanças recentes na rotina de cuidado.

Apetite e desconforto físico: Redução do apetite, náusea, mal-estar gastrointestinal ou perda de peso podem repercutir na sessão como menor tolerância, cansaço e recusa de atividades. Em pacientes com demência, esses sinais facilmente se misturam com dificuldade de nomear sensações corporais, infecções, dor, constipação ou outras medicações em uso. Vale observar se o desconforto aparece associado a horários previsíveis, recusa alimentar nova ou queda funcional mais ampla.

Adesão e manejo do cuidado: Com essa associação, a adesão costuma depender menos da intenção do paciente e mais da organização do cuidador, da rotina da casa e da compreensão do esquema de uso. Na sessão, inconsistências no relato, piora em “dentes de serra” ou divergência entre paciente e familiar podem sinalizar uso irregular sem que ninguém nomeie isso claramente. O trabalho clínico é mapear quem administra, como percebem mudanças e se houve alterações recentes na logística do cuidado.

Vínculo e sustentação: À medida que o comprometimento cognitivo avança, o enquadre pode precisar de mais repetição, linguagem concreta e metas mais modestas, sem perder o eixo subjetivo do encontro. O risco é ler como “resistência” aquilo que já é limitação de memória, atenção ou compreensão. Também vale notar como a medicação entra simbolicamente na sessão: como esperança de estabilização, marcador de gravidade ou fonte de tensão entre paciente, família e equipe."

O que observar em sessão

- **Cognição prática:** Na sessão, podem aparecer esquecimentos mais evidentes, repetição de perguntas, perda do fio da conversa e dificuldade para acompanhar combinações simples. O ponto clínico é distinguir declínio progressivo esperado do quadro de base de uma mudança mais brusca no padrão habitual, que pode sugerir intercorrência clínica, oscilação do uso ou desorganização ambiental. Vale comparar com a linha de base recente: o paciente está parecido com as últimas semanas ou houve uma inflexão nítida?.

Ritmo e vigília: Alguns pacientes chegam mais lentificados, sonolentos ou com menor iniciativa, enquanto outros oscilam bastante ao longo do dia. Isso pode ser confundido com apatia do quadro neurocognitivo, depressão, noites mal dormidas ou rotina de cuidados desorganizada. Na observação clínica, ajuda notar se a queda de presença mental é constante na sessão ou se varia conforme horário, contexto e qualidade do sono relatada.

Humor e irritabilidade: Irritabilidade, impaciência, retraimento ou maior labilidade emocional podem aparecer mais como mudança de manejo afetivo do que como queixa espontânea. Nem sempre isso aponta para efeito da medicação; frustração diante das perdas cognitivas, conflitos com cuidadores e sensação de dependência costumam pesar bastante. O terapeuta ganha precisão quando observa se a alteração afetiva acompanha piora funcional global, eventos de vida ou mudanças recentes na rotina de cuidado.

Apetite e desconforto físico: Redução do apetite, náusea, mal-estar gastrointestinal ou perda de peso podem repercutir na sessão como menor tolerância, cansaço e recusa de atividades. Em pacientes com demência, esses sinais facilmente se misturam com dificuldade de nomear sensações corporais, infecções, dor, constipação ou outras medicações em uso. Vale observar se o desconforto aparece associado a horários previsíveis, recusa alimentar nova ou queda funcional mais ampla.

Adesão e manejo do cuidado: Com essa associação, a adesão costuma depender menos da intenção do paciente e mais da organização do cuidador, da rotina da casa e da compreensão do esquema de uso. Na sessão, inconsistências no relato, piora em “dentes de serra” ou divergência entre paciente e familiar podem sinalizar uso irregular sem que ninguém nomeie isso claramente. O trabalho clínico é mapear quem administra, como percebem mudanças e se houve alterações recentes na logística do cuidado.

Vínculo e sustentação: À medida que o comprometimento cognitivo avança, o enquadre pode precisar de mais repetição, linguagem concreta e metas mais modestas, sem perder o eixo subjetivo do encontro. O risco é ler como “resistência” aquilo que já é limitação de memória, atenção ou compreensão. Também vale notar como a medicação entra simbolicamente na sessão: como esperança de estabilização, marcador de gravidade ou fonte de tensão entre paciente, família e equipe.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Associação usada sobretudo em quadros neurocognitivos, em especial demência de Alzheimer em fases moderadas a mais avançadas. No consultório, o foco raramente é “efeito do remédio” isolado: importa acompanhar se, ao longo de semanas a poucos meses, há estabilização, piora progressiva ou flutuação do funcionamento, e como isso repercute em autonomia, vínculo e tolerância ao cuidado. Mudanças abruptas tendem a pedir leitura cautelosa, porque podem refletir intercorrências clínicas, adesão irregular, sobrecarga do cuidador ou progressão do quadro de base. A sessão costuma girar em torno de cognição prática, ritmo, apetite, sono e sustentação do trabalho terapêutico.

Perguntas úteis

- "Essa dificuldade que você percebe está parecida com o que vinha acontecendo aos poucos ou houve uma mudança mais nítida nos últimos dias ou semanas? , Quando você fica mais confuso ou mais lento, isso costuma acontecer em algum período do dia ou aparece do mesmo jeito o tempo todo? , Nessas últimas semanas, você tem se sentido mais triste e sem vontade de fazer as coisas, ou a principal dificuldade é mais esquecer, se perder e não conseguir acompanhar? , Quem tem organizado seus remédios e a rotina de cuidados, e houve algum dia em que isso saiu do habitual? , Essa irritação aparece mais quando você é contrariado ou ajudado em algo, ou você se percebe diferente mesmo em momentos tranquilos? , Seu apetite e sua disposição para comer mudaram junto com essa piora, ou isso parece separado das dificuldades de memória e atenção?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando há piora cognitiva ou funcional mais abrupta do que a linha de base recente
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar progressão esperada de intercorrência clínica ou uso irregular
- Quando sonolência
- lentificação ou apatia passam a comprometer de modo claro a participação na sessão e a rotina
- pode valer comunicar o médico para revisão do quadro e da tolerabilidade
- Quando surgem náusea persistente
- recusa alimentar ou perda de peso percebida por paciente ou cuidador
- pode valer alinhar com o médico pela repercussão funcional e risco de abandono silencioso do tratamento
- Quando o relato do paciente e do cuidador sugere falhas frequentes na administração ou mudanças recentes na rotina de medicação
- pode valer comunicar o médico para contextualizar oscilações clínicas
- Quando aparecem irritabilidade ou agitação novas
- sobretudo se vierem junto de piora global do funcionamento
- pode valer alinhar com o médico para avaliar se há fator clínico associado além da evolução do quadro

Vermelho: tratar como urgência

- Confusão muito mais intensa que o habitual
- com rebaixamento importante da atenção
- fala muito desconexa ou incapacidade súbita de se orientar minimamente durante a sessão.: Tratar como mudança aguda do estado mental
- acionar familiar ou cuidador e buscar avaliação médica no mesmo dia; emergência se houver impossibilidade de manejo seguro
- Aparecem ideias de morte
- desesperança intensa ou comportamento autoagressivo em paciente que antes não vinha se apresentando assim.: Fazer avaliação imediata de risco
- acionar rede de apoio e médico assistente no mesmo dia
- recorrendo à emergência quando necessário

Frase clínica

Nesta associação, o foco clínico é diferenciar progressão do quadro neurocognitivo de mudanças abruptas ligadas a intercorrências, adesão e sobrecarga do cuidado.

162 DONANEMABE

Substância: Donanemabe.

Nomes Comerciais: Kisunla

Uso comum

- Donanemabe é um biológico usado no tratamento da doença de Alzheimer em contexto especializado, ainda pouco frequente no consultório de psicoterapia. Aqui, o foco clínico tende a recair menos sobre efeitos subjetivos específicos do medicamento e mais sobre como o paciente e a família atravessam um tratamento contínuo, com monitoramento médico e expectativa elevada em torno de declínio cognitivo e funcionalidade. Ao longo de semanas e meses, vale acompanhar se mudanças percebidas na sessão acompanham a linha de base do quadro neurocognitivo, oscilações emocionais diante do diagnóstico, intercorrências clínicas ou sobrecarga do tratamento.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como rotina médica intensa, deslocamentos, exames, conversas familiares e expectativa de “estabilizar” ou “ganhar tempo”. Isso às vezes aparece como cansaço, irritabilidade, menor disponibilidade psíquica para elaboração ou sensação de que a vida passou a girar em torno do acompanhamento. Pode confundir a leitura quando a redução de engajamento terapêutico decorre menos de piora emocional e mais de fadiga logística, sobrecarga do cuidador ou intercorrências clínicas fora do setting.

Funcionalidade e identidade: Mudanças em memória, iniciativa, organização e autonomia tendem a ser mais centrais na sessão do que uma vivência subjetiva clara de efeito medicamentoso. O terapeuta pode notar maior concretude, dificuldade de acompanhar encadeamentos, repetição de temas ou oscilação na consciência das próprias perdas. Nem toda diferença entre sessões indica progressão do quadro: estresse, privação de sono, ambiente novo, ajuda excessiva da família ou adesão irregular ao conjunto do tratamento também podem alterar o desempenho aparente.

Vínculo e rede: A presença crescente de familiares ou cuidadores no entorno do tratamento costuma repercutir no vínculo terapêutico, na privacidade e no lugar de fala do paciente. Em sessão, pode surgir ambivalência entre querer apoio e sentir-se tutelado, além de conflitos sobre decisões práticas, segurança e autonomia. Vale diferenciar quando a tensão vem de mudanças cognitivas do paciente e quando decorre de desencontro entre expectativas da família, comunicação com a equipe e luto antecipatório."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como rotina médica intensa, deslocamentos, exames, conversas familiares e expectativa de “estabilizar” ou “ganhar tempo”. Isso às vezes aparece como cansaço, irritabilidade, menor disponibilidade psíquica para elaboração ou sensação de que a vida passou a girar em torno do acompanhamento. Pode confundir a leitura quando a redução de engajamento terapêutico decorre menos de piora emocional e mais de fadiga logística, sobrecarga do cuidador ou intercorrências clínicas fora do setting.

Funcionalidade e identidade: Mudanças em memória, iniciativa, organização e autonomia tendem a ser mais centrais na sessão do que uma vivência subjetiva clara de efeito medicamentoso. O terapeuta pode notar maior concretude, dificuldade de acompanhar encadeamentos, repetição de temas ou oscilação na consciência das próprias perdas. Nem toda diferença entre sessões indica progressão do quadro: estresse, privação de sono, ambiente novo, ajuda excessiva da família ou adesão irregular ao conjunto do tratamento também podem alterar o desempenho aparente.

Vínculo e rede: A presença crescente de familiares ou cuidadores no entorno do tratamento costuma repercutir no vínculo terapêutico, na privacidade e no lugar de fala do paciente. Em sessão, pode surgir ambivalência entre querer apoio e sentir-se tutelado, além de conflitos sobre decisões práticas, segurança e autonomia. Vale diferenciar quando a tensão vem de mudanças cognitivas do paciente e quando decorre de desencontro entre expectativas da família, comunicação com a equipe e luto antecipatório.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Donanemabe é um biológico usado no tratamento da doença de Alzheimer em contexto especializado, ainda pouco frequente no consultório de psicoterapia. Aqui, o foco clínico tende a recair menos sobre efeitos subjetivos específicos do medicamento e mais sobre como o paciente e a família atravessam um tratamento contínuo, com monitoramento médico e expectativa elevada em torno de declínio cognitivo e funcionalidade. Ao longo de semanas e meses, vale acompanhar se mudanças percebidas na sessão acompanham a linha de base do quadro neurocognitivo, oscilações emocionais diante do diagnóstico, intercorrências clínicas ou sobrecarga do tratamento.

Perguntas úteis

- "Quando você sente que está “pior” desde o início desse tratamento, isso aparece mais como esquecimento e dificuldade prática no dia a dia ou mais como desânimo, medo e frustração com a situação? , Nas semanas em que você vem mais cansado ou menos disponível na sessão, isso costuma acontecer depois de exames, deslocamentos e consultas, ou é algo que permanece mesmo fora desses dias? , Quando sua família diz que houve mudança, você percebe a mesma coisa em você ou sente que a principal mudança está em como passaram a te observar e ajudar? , As dificuldades que apareceram recentemente são parecidas com seu padrão habitual ou houve uma mudança mais brusca, em poucos dias, no seu jeito de pensar, falar ou se orientar? , Quando você evita atividades ou decisões, isso parece vir mais de não conseguir organizar os passos ou de receio de errar e se expor diante dos outros?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente ou a família descrevem mudança mais brusca do funcionamento em poucos dias
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar progressão esperada de intercorrência clínica durante o tratamento
- Quando a rotina de exames
- infusões e deslocamentos passa a comprometer fortemente presença
- engajamento ou continuidade do cuidado psíquico
- pode valer comunicar para situar o impacto funcional do tratamento no cotidiano
- Quando surgem conflitos familiares importantes sobre autonomia
- segurança ou tomada de decisão
- pode valer alinhar com a equipe médica para compartilhar como isso está repercutindo no funcionamento e no vínculo
- Quando o paciente demonstra pouca compreensão do que está sendo feito
- mas concorda passivamente com tudo
- pode valer contato com o médico assistente para situar dúvidas sobre participação nas decisões e necessidade de comunicação mais ajustada

Vermelho: tratar como urgência

- Mudança nítida e recente
- em horas ou poucos dias
- com confusão maior que o habitual
- fala muito desorganizada
- pior orientação ou rebaixamento importante do contato em sessão.: Acionar avaliação médica no mesmo dia e
- se necessário
- rede de apoio e serviço de urgência
- registrando o contraste com a linha de base conhecida
- Aparecimento de ideação suicida
- desesperança intensa ou fala de não querer seguir vivendo no contexto do diagnóstico e do tratamento.: Fazer manejo clínico de risco imediatamente
- acionar rede de apoio e avaliação médica no mesmo dia conforme a gravidade

Frase clínica

Com donanemabe, o foco da sessão costuma estar menos no fármaco e mais na trajetória do Alzheimer, na carga do tratamento e na mudança de funcionalidade.

163 LECANEMABE

Substância: Lecanemabe.

Nomes Comerciais: Leqembi

Uso comum

- Lecanemabe é um biológico usado no tratamento da doença de Alzheimer em contexto especializado, geralmente em acompanhamento neurológico contínuo e com monitoramento por imagem. No consultório de terapia, ele tende a aparecer menos como tema farmacológico e mais como parte de um percurso de doença neurodegenerativa, com idas regulares a serviços de saúde, expectativa de estabilização e incerteza sobre mudanças sutis ao longo de semanas e meses. O ponto central de observação não é “efeito do remédio” em si, mas como paciente e família leem oscilações de memória, autonomia, medo de piora e carga do tratamento.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como rotina médica exigente, deslocamentos, exames, infusões e reorganização da vida em torno do cuidado. Isso às vezes produz cansaço, irritação ou sensação de que a vida ficou reduzida ao papel de paciente, o que pode ser confundido com piora depressiva ou desmotivação primária. Vale observar se o peso subjetivo está ligado aos dias de procedimento e à antecipação das consultas, ou se se mantém de modo mais difuso independentemente do calendário de cuidados.

Funcionalidade e identidade: Mudanças na memória, na iniciativa e na autonomia costumam mobilizar vergonha, retraimento e luto pela perda de competências antes estáveis. Na sessão, pode aparecer oscilação entre minimização, dependência crescente e esforço de preservar uma imagem de si menos marcada pela doença. Nem toda dificuldade cotidiana indica progressão linear do quadro; estresse, ambiente novo, sobrecarga familiar e diferenças entre dias melhores e piores também podem alterar o desempenho observado.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, exames e decisões de seguimento pode ganhar forte carga afetiva, com esperança intensa, desconfiança ou sensação de estar sendo conduzido por um processo pouco compreendido. Isso repercute no vínculo terapêutico quando o paciente busca confirmação, evita falar de medos ou desloca para a sessão frustrações com o sistema de cuidado. Convém diferenciar resistência ao tratamento, dificuldade cognitiva para acompanhar orientações e ambivalência emocional diante de uma doença progressiva."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode entrar na sessão como rotina médica exigente, deslocamentos, exames, infusões e reorganização da vida em torno do cuidado. Isso às vezes produz cansaço, irritação ou sensação de que a vida ficou reduzida ao papel de paciente, o que pode ser confundido com piora depressiva ou desmotivação primária. Vale observar se o peso subjetivo está ligado aos dias de procedimento e à antecipação das consultas, ou se se mantém de modo mais difuso independentemente do calendário de cuidados.

Funcionalidade e identidade: Mudanças na memória, na iniciativa e na autonomia costumam mobilizar vergonha, retraimento e luto pela perda de competências antes estáveis. Na sessão, pode aparecer oscilação entre minimização, dependência crescente e esforço de preservar uma imagem de si menos marcada pela doença. Nem toda dificuldade cotidiana indica progressão linear do quadro; estresse, ambiente novo, sobrecarga familiar e diferenças entre dias melhores e piores também podem alterar o desempenho observado.

Vínculo com a equipe: A relação com neurologista, exames e decisões de seguimento pode ganhar forte carga afetiva, com esperança intensa, desconfiança ou sensação de estar sendo conduzido por um processo pouco compreendido. Isso repercute no vínculo terapêutico quando o paciente busca confirmação, evita falar de medos ou desloca para a sessão frustrações com o sistema de cuidado. Convém diferenciar resistência ao tratamento, dificuldade cognitiva para acompanhar orientações e ambivalência emocional diante de uma doença progressiva.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Lecanemabe é um biológico usado no tratamento da doença de Alzheimer em contexto especializado, geralmente em acompanhamento neurológico contínuo e com monitoramento por imagem. No consultório de terapia, ele tende a aparecer menos como tema farmacológico e mais como parte de um percurso de doença neurodegenerativa, com idas regulares a serviços de saúde, expectativa de estabilização e incerteza sobre mudanças sutis ao longo de semanas e meses. O ponto central de observação não é “efeito do remédio” em si, mas como paciente e família leem oscilações de memória, autonomia, medo de piora e carga do tratamento.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe um dia pior, isso costuma acontecer mais perto de exames, infusões ou consultas, ou aparece sem relação clara com esses momentos? , Nas situações em que você se sente mais confuso ou esquecido, o que muda: o ambiente, o cansaço, a pressão das pessoas à sua volta ou parece vir do mesmo jeito em qualquer contexto? , Quando você evita alguma atividade, isso tem mais a ver com medo de não dar conta, com desânimo, ou com dificuldade prática que antes não existia? , Quando você fala do tratamento, o que pesa mais hoje: o esforço da rotina médica, a incerteza sobre o futuro, ou a sensação de perda de autonomia?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente ou a família descrevem piora cognitiva ou funcional mais abrupta do que o padrão habitual

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer alinhar com o médico assistente para situar se houve mudança clínica relevante no curso recente
- Quando surgem cefaleia nova ou mais intensa
- confusão incomum
- maior lentificação ou alteração neurológica percebida na sessão
- pode valer contato em curto prazo pela necessidade de avaliação médica
- Quando a carga do tratamento está levando a faltas recorrentes
- recusa de exames ou abandono silencioso do seguimento
- pode valer comunicar o médico para alinhamento do cuidado e manejo da adesão
- Quando o paciente passa a interpretar qualquer oscilação cotidiana como prova de fracasso do tratamento
- pode ser útil alinhar com a equipe para evitar leituras extremadas que desorganizem o seguimento

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- aparece rebaixamento importante do nível de alerta
- desorientação acentuada
- fala muito mais confusa que o habitual ou alteração neurológica súbita percebida pelo terapeuta ou acompanhante.: Acionar avaliação médica no mesmo dia
- envolvendo rede de apoio e serviço de urgência quando necessário

Frase clínica

O foco clínico é menos o fármaco e mais como a doença, o monitoramento e a perda de autonomia reorganizam a vida psíquica e relacional.

164 CLORIDRATO DE NALTREXONA

Substância: Cloridrato de Naltrexona.

Nomes Comerciais: Revia, Uninaltrex

Uso comum

- A naltrexona é um modulador usado sobretudo em contextos de dependência de álcool e opioides, e às vezes aparece na terapia quando o paciente está tentando sustentar abstinência, reduzir recaídas ou reorganizar a rotina após uso problemático. Nas primeiras semanas, o foco costuma recair menos em “sentir efeito” e mais em mudanças no padrão de fissura, no impulso de usar e na relação subjetiva com o consumo; ao longo de 4 a 8 semanas, vale observar se há maior capacidade de interromper escaladas ou se o paciente segue em ciclos semelhantes. Na sessão, o ponto central é diferenciar redução de reforço do uso, adesão irregular, recaída silenciosa e sofrimento psíquico que o consumo antes amortecia.

O paciente pode relatar

- **"Fissura e impulso:** Alguns pacientes descrevem menor urgência para beber ou usar, enquanto outros seguem com pensamento recorrente sobre consumo, mas com experiência subjetiva diferente na hora de agir. Na sessão, isso pode aparecer como mais espaço entre impulso e ato, ou como frustração por ainda haver desejo apesar da medicação. A leitura pode se confundir com motivação inicial de tratamento, pressão familiar, maior monitoramento externo ou, ao contrário, com adesão irregular que mantém o padrão de fissura praticamente inalterado.

Recaída e reforço: Quando há uso durante o tratamento, o paciente pode relatar que a experiência foi "menos compensadora", mais estranha ou menos capaz de interromper sofrimento emocional do que antes. Isso pode favorecer elaboração clínica mais reflexiva, mas também pode gerar teste repetido da substância, numa tentativa de recuperar o efeito conhecido. Em sessão, convém diferenciar esse movimento de recaída franca, ambivalência esperada no processo de mudança e uso episódico omitido por vergonha ou medo de julgamento.

Humor sem anestesia: À medida que o consumo perde parte da função de alívio imediato, afetos antes amortecidos podem ficar mais visíveis no consultório: irritabilidade, vazio, tristeza, culpa ou ansiedade. Nem sempre isso indica piora causada pela medicação; muitas vezes coincide com abstinência inicial, luto pelo lugar da substância na vida ou reaparecimento do quadro de base. Vale observar se o paciente está mais acessível afetivamente e elaborando melhor, ou apenas mais sofrido e desorganizado desde que reduziu o uso.

Adesão e ambivalência: A adesão pode oscilar de modo silencioso, especialmente quando o paciente sente pouca diferença imediata, quer testar se "já consegue sozinho" ou evita tomar em dias em que cogita usar. Na sessão, isso às vezes aparece como narrativa vaga sobre rotina, inconsistência entre intenção e comportamento ou explicações pouco estáveis para lapsos. O risco clínico é atribuir tudo à resistência psicológica ou à gravidade da dependência quando parte do quadro pode estar ligada a uso irregular da medicação.

Rotina e identidade: Com menor centralidade do consumo, surgem questões práticas e identitárias que a substância antes organizava ou encobria: tempo livre, sociabilidade, sexualidade, tédio, culpa e redefinição de pertencimento. O paciente pode parecer mais presente e disponível para o trabalho terapêutico, mas também mais confrontado com conflitos antigos. Isso pode ser confundido com "piora" quando, na verdade, o tratamento está deslocando o foco do ato de usar para a vida que fica exposta sem ele."

O que observar em sessão

- **Fissura e impulso:** Alguns pacientes descrevem menor urgência para beber ou usar, enquanto outros seguem com pensamento recorrente sobre consumo, mas com experiência subjetiva diferente na hora de agir. Na sessão, isso pode aparecer como mais espaço entre impulso e ato, ou como frustração por ainda haver desejo apesar da medicação. A leitura pode se confundir com motivação inicial de tratamento, pressão familiar, maior monitoramento externo ou, ao contrário, com adesão irregular que mantém o padrão de fissura praticamente inalterado.

Recaída e reforço: Quando há uso durante o tratamento, o paciente pode relatar que a experiência foi “menos compensadora”, mais estranha ou menos capaz de interromper sofrimento emocional do que antes. Isso pode favorecer elaboração clínica mais reflexiva, mas também pode gerar teste repetido da substância, numa tentativa de recuperar o efeito conhecido. Em sessão, convém diferenciar esse movimento de recaída franca, ambivalência esperada no processo de mudança e uso episódico omitido por vergonha ou medo de julgamento.

Humor sem anestesia: À medida que o consumo perde parte da função de alívio imediato, afetos antes amortecidos podem ficar mais visíveis no consultório: irritabilidade, vazio, tristeza, culpa ou ansiedade. Nem sempre isso indica piora causada pela medicação; muitas vezes coincide com abstinência inicial, luto pelo lugar da substância na vida ou reaparecimento do quadro de base. Vale observar se o paciente está mais acessível afetivamente e elaborando melhor, ou apenas mais sofrido e desorganizado desde que reduziu o uso.

Adesão e ambivalência: A adesão pode oscilar de modo silencioso, especialmente quando o paciente sente pouca diferença imediata, quer testar se “já consegue sozinho” ou evita tomar em dias em que cogita usar. Na sessão, isso às vezes aparece como narrativa vaga sobre rotina, inconsistência entre intenção e comportamento ou explicações pouco estáveis para lapsos. O risco clínico é atribuir tudo à resistência psicológica ou à gravidade da dependência quando parte do quadro pode estar ligada a uso irregular da medicação.

Rotina e identidade: Com menor centralidade do consumo, surgem questões práticas e identitárias que a substância antes organizava ou encobria: tempo livre, sociabilidade, sexualidade, tédio, culpa e redefinição de pertencimento. O paciente pode parecer mais presente e disponível para o trabalho terapêutico, mas também mais confrontado com conflitos antigos. Isso pode ser confundido com “piora” quando, na verdade, o tratamento está deslocando o foco do ato de usar para a vida que fica exposta sem ele.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A naltrexona é um modulador usado sobretudo em contextos de dependência de álcool e opioides, e às vezes aparece na terapia quando o paciente está tentando sustentar abstinência, reduzir recaídas ou reorganizar a rotina após uso problemático. Nas primeiras semanas, o foco costuma recair menos em “sentir efeito” e mais em mudanças no padrão de fissura, no impulso de usar e na relação subjetiva com o consumo; ao longo de 4 a 8 semanas, vale observar se há maior capacidade de interromper escaladas ou se o paciente segue em ciclos semelhantes. Na sessão, o ponto central é diferenciar redução de reforço do uso, adesão irregular, recaída silenciosa e sofrimento psíquico que o consumo antes amortecia.

Perguntas úteis

- "Quando a vontade de usar aparece, você sente que ela diminui com o tempo ou continua igual e só muda o quanto você consegue segurar o impulso? , Nas vezes em que houve uso desde que começou o tratamento, a experiência pareceu parecida com a de antes ou ficou diferente de um jeito que mudou sua relação com a recaída? , Nos dias em que você não toma ou toma fora da rotina, o que costuma acontecer com a fissura, com o risco de usar e com a forma como você conta isso para si mesmo? , O sofrimento que apareceu recentemente se parece com algo que já estava aí antes do tratamento, ou surgiu mais como efeito de ficar sem o recurso que você usava para se anestesiar? , Quando você pensa em interromper, esquecer ou evitar a medicação, isso vem mais de incômodo físico, de sensação de inutilidade ou de uma parte sua que ainda quer deixar aberta a possibilidade de usar?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente mantém uso recorrente de álcool ou opioides e descreve pouca mudança no impulso ou no padrão de recaída após várias semanas
- pode valer alinhar com o médico para revisar o curso clínico e a adesão
- Quando surgem sinais consistentes de adesão irregular
- especialmente omissão deliberada em dias de maior risco de uso
- pode valer comunicar o médico pela relevância disso na leitura da resposta ao tratamento
- Quando o paciente relata piora importante de humor
- irritabilidade ou ansiedade após reduzir o consumo
- com impacto funcional claro
- pode valer alinhar com o médico para discriminar sofrimento de abstinência
- quadro de base e tolerabilidade
- Quando aparecem efeitos físicos persistentes que aumentam a chance de abandono silencioso da medicação
- pode valer comunicar o médico porque a adesão pode se perder sem que o paciente verbalize espontaneamente
- Quando há recaídas repetidas acompanhadas de vergonha intensa
- ocultação ou afastamento do tratamento
- pode valer contato com o médico para favorecer uma leitura compartilhada do risco clínico e da continuidade do cuidado

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente chega à sessão com ideação suicida atual
- desesperança acentuada e recaída recente ou risco iminente de voltar a usar.: Avaliar risco imediatamente
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia

Vermelho: tratar como urgência

- recorrendo a emergência quando necessário
- Há relato de uso recente de opioides em contexto de mal-estar intenso
- confusão
- sonolência importante ou rebaixamento do estado geral.: Interromper o manejo apenas verbal da sessão e orientar busca de avaliação médica urgente
- com acionamento de emergência se houver comprometimento importante

Frase clínica

O foco clínico é distinguir redução real do impulso de usar, adesão irregular e sofrimento que emerge quando a substância perde função de anestesia.

165 CLORIDRATO DE NALOXONA

Substância: Cloridrato de Naloxona.

Nomes Comerciais: Narcan, Cloridrato de Naloxona

Uso comum

- Cloridrato de naloxona é um antagonista de opioides usado em contexto agudo para reverter intoxicação por essas substâncias. No consultório de terapia, sua presença tende a indicar que o paciente passou por overdose recente, atendimento de urgência ou convive com risco elevado relacionado ao uso de opioides, mais do que um tratamento contínuo em si. As horas e os primeiros dias após o evento costumam concentrar instabilidade física e emocional; nas semanas seguintes, o foco clínico passa a ser medo de nova overdose, vergonha, negação do risco, fissura, luto pelo episódio e oscilação na adesão ao cuidado. O ponto central na sessão é diferenciar sofrimento pós-crise, abstinência, recaída em curso e minimização do risco.

O paciente pode relatar

- **"Pós-overdose:** Quando a naloxona aparece na história, frequentemente o dado clinicamente mais relevante não é o medicamento, mas o episódio que levou ao seu uso. Na sessão, podem surgir lacunas de memória, vergonha, susto, irritabilidade, sensação de invulnerabilidade ou minimização do ocorrido. Isso pode se confundir com defesa psíquica, efeito residual de outras substâncias, abstinência ou com a própria desorganização de vida que antecede o evento, por isso vale ancorar a leitura na linha de base anterior e no que mudou depois do episódio.

Abstinência e fissura: Após reversão de opioides, parte dos pacientes pode chegar à sessão em intenso desconforto, agitação, dores, náusea, irritabilidade ou urgência de usar novamente para aliviar o mal-estar. Na escuta, isso pode parecer apenas ansiedade extrema ou impulsividade habitual, mas o encadeamento temporal com uso recente, overdose ou atendimento de urgência ajuda a discriminar. Também convém considerar outras substâncias em jogo, já que sedativos, álcool e estimulantes podem embaralhar a apresentação clínica.

Risco e negação: Alguns pacientes passam a reconhecer a gravidade do risco; outros reduzem o episódio a um acidente sem maior significado. Na sessão, essa diferença aparece na forma como falam de dose, contexto de uso, uso solitário, mistura de substâncias e disponibilidade de ajuda em caso de nova emergência. Eventos de vida, vergonha e medo de julgamento podem levar tanto à minimização quanto a narrativas dramáticas, e a adesão irregular ao acompanhamento costuma aumentar essa opacidade.

Vínculo e continuidade: Depois de uma emergência, é comum haver oscilação entre pedido de ajuda, evasão, faltas e comparecimento defensivo. O terapeuta pode notar empobrecimento da elaboração, urgência concreta, dificuldade de sustentar associação livre e maior sensibilidade a qualquer vivência de controle. Isso nem sempre indica resistência no sentido habitual; pode refletir exaustão, abstinência, recaída em curso, medo de internação ou relação ambivalente com a rede de cuidado."

O que observar em sessão

- **Pós-overdose:** Quando a naloxona aparece na história, frequentemente o dado clinicamente mais relevante não é o medicamento, mas o episódio que levou ao seu uso. Na sessão, podem surgir lacunas de memória, vergonha, susto, irritabilidade, sensação de invulnerabilidade ou minimização do ocorrido. Isso pode se confundir com defesa psíquica, efeito residual de outras substâncias, abstinência ou com a própria desorganização de vida que antecede o evento, por isso vale ancorar a leitura na linha de base anterior e no que mudou depois do episódio.

Abstinência e fissura: Após reversão de opioides, parte dos pacientes pode chegar à sessão em intenso desconforto, agitação, dores, náusea, irritabilidade ou urgência de usar novamente para aliviar o mal-estar. Na escuta, isso pode parecer apenas ansiedade extrema ou impulsividade habitual, mas o encadeamento temporal com uso recente, overdose ou atendimento de urgência ajuda a discriminar. Também convém considerar outras substâncias em jogo, já que sedativos, álcool e estimulantes podem embaralhar a apresentação clínica.

Risco e negação: Alguns pacientes passam a reconhecer a gravidade do risco; outros reduzem o episódio a um acidente sem maior significado. Na sessão, essa diferença aparece na forma como falam de dose, contexto de uso, uso solitário, mistura de substâncias e disponibilidade de ajuda em caso de nova emergência. Eventos de vida, vergonha e medo de julgamento podem levar tanto à minimização quanto a narrativas dramáticas, e a adesão irregular ao acompanhamento costuma aumentar essa opacidade.

Vínculo e continuidade: Depois de uma emergência, é comum haver oscilação entre pedido de ajuda, evasão, faltas e comparecimento defensivo. O terapeuta pode notar empobrecimento da elaboração, urgência concreta, dificuldade de sustentar associação livre e maior sensibilidade a qualquer vivência de controle. Isso nem sempre indica resistência no sentido habitual; pode refletir exaustão, abstinência, recaída em curso, medo de internação ou relação ambivalente com a rede de cuidado.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Cloridrato de naloxona é um antagonista de opioides usado em contexto agudo para reverter intoxicação por essas substâncias. No consultório de terapia, sua presença tende a indicar que o paciente passou por overdose recente, atendimento de urgência ou convive com risco elevado relacionado ao uso de opioides, mais do que um tratamento contínuo em si. As horas e os primeiros dias após o evento costumam concentrar instabilidade física e emocional; nas semanas seguintes, o foco clínico passa a ser medo de nova overdose, vergonha, negação do risco, fissura, luto pelo episódio e oscilação na adesão ao cuidado. O ponto central na sessão é diferenciar sofrimento pós-crise, abstinência, recaída em curso e minimização do risco.

Perguntas úteis

- "Desde o episódio em que recebeu atendimento, o que mudou concretamente no seu uso: você ficou mais cauteloso, tentou parar, voltou ao padrão anterior ou passou a usar para aliviar um mal-estar que apareceu depois? , Quando você fala que ficou muito agitado ou angustiado depois disso, essa sensação se parece com a sua ansiedade de costume ou veio junto com desconforto físico e urgência de usar alguma substância? , O que, na sua leitura, tornou aquele episódio possível: quantidade usada, mistura com outras substâncias, uso sozinho, perda de tolerância ou algo do contexto daquele dia? , Desde então, você tem evitado falar do assunto porque sente vergonha ou porque acha que o risco foi exagerado e não vê muita relação com o que aconteceu? , Nas últimas semanas, quando você faltou, se isolou ou chegou mais embotado, isso aconteceu mais em dias de uso, de fissura, de ressaca, ou em momentos de conflito e sobrecarga emocional?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve nova perda de consciência
- uso repetido em contexto de alto risco ou mistura recorrente de opioides com outras substâncias depressores
- pode valer alinhar com o médico assistente para atualização do risco e do plano de cuidado
- Quando a sessão sugere abstinência importante
- fissura intensa ou retorno rápido ao uso após uma overdose recente
- pode valer comunicar o médico para melhor coordenação do acompanhamento nas próximas horas ou dias
- Quando o paciente minimiza de forma persistente um episódio grave
- omite recaídas relevantes ou abandona seguimento logo após atendimento de urgência
- pode valer alinhar com o médico pela alta vulnerabilidade clínica
- Quando surgem ideação suicida
- desesperança acentuada ou narrativa de indiferença diante da possibilidade de morrer no contexto de uso
- pode valer contato com o médico para avaliação conjunta do risco
- Quando há confusão importante sobre quais substâncias foram usadas e em que contexto ocorreu a reversão
- pode valer comunicação para reduzir pontos cegos na leitura clínica do episódio

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente chega à sessão sonolento
- com fala muito arrastada
- dificuldade de se manter acordado ou respiração visivelmente lenta após uso recente ou suspeito de opioides.: Interrompa o enquadre habitual
- acione atendimento de urgência e rede de apoio imediata

Vermelho: tratar como urgência

- mantendo supervisão até a chegada de ajuda
- Surge relato de nova overdose
- perda de consciência recente ou uso novamente em condições muito semelhantes às do episódio anterior
- especialmente se houve uso sozinho ou mistura de substâncias.: Trate como risco atual elevado
- acione o médico e a rede de apoio no mesmo dia e encaminhe para avaliação urgente quando necessário
- O paciente expressa que não se importa se morrer
- descreve uso com expectativa de não acordar ou apresenta ideação suicida associada ao consumo.: Faça manejo imediato de risco
- acione psiquiatra e rede de apoio hoje e encaminhe para emergência se não houver segurança para manejo ambulatorial

Frase clínica

Com naloxona, o foco da terapia é o que a overdose revela: risco atual, negação, abstinência, fissura e continuidade possível do cuidado.

166 CLORIDRATO DE ATOMOXETINA

Substância: Cloridrato de Atomoxetina.

Nomes Comerciais: Atentah, Cloridrato de Atomoxetina

Uso comum

- A atomoxetina é um medicamento usado sobretudo no TDAH, inclusive quando o paciente chega à terapia com queixas de desatenção, impulsividade, desorganização e repercussões acadêmicas, profissionais ou relacionais. Diferente de medicações de efeito mais imediato, a mudança costuma ser acompanhada ao longo de 2 a 6 semanas, às vezes com leitura mais nítida apenas após algumas semanas adicionais. No consultório, o ponto central é distinguir melhora gradual de autorregulação e sustentação atencional de oscilação por rotina, sono, ansiedade, expectativas iniciais ou uso irregular, além de observar se a ativação inicial ou desconfortos corporais estão interferindo na adesão.

O paciente pode relatar

- **"Atenção e rotina:** Em parte dos pacientes, a sessão começa a mostrar menos dispersão, maior capacidade de retomar o fio da conversa e alguma melhora na execução de tarefas entre sessões. Isso pode se confundir com fases de maior estrutura externa, cobrança ambiental, início de semestre, mudança de trabalho ou simples efeito de novidade por ter começado um tratamento. Vale comparar a linha de base com exemplos concretos do cotidiano e observar se a melhora aparece de modo relativamente consistente, e não apenas em dias mais organizados ou motivados.

Ativação e ansiedade: No início, alguns pacientes ficam mais acelerados, irritáveis ou corporalmente tensos, e isso pode ser vivido como piora da ansiedade ou como sensação de estar ligado demais. Na sessão, o terapeuta pode notar fala mais apressada, menor tolerância à frustração e dificuldade de permanecer em um tema, mas esse quadro também pode refletir estresse recente, privação de sono, cafeína, outras substâncias ou o próprio TDAH em contexto de maior demanda. A discriminação clínica depende de mapear temporalidade, intensidade e relação com o início do uso.

Sono e apetite: Alterações de sono e redução de apetite podem aparecer e, quando persistem, tendem a contaminar humor, tolerância emocional e funcionamento executivo, produzindo uma impressão de piora global. Na sessão, isso pode surgir como cansaço, irritabilidade, menor disponibilidade associativa ou relato de refeições puladas, mas o mesmo padrão também ocorre em fases de ansiedade, rotina caótica, sobrecarga acadêmica ou laboral e hábitos já prévios. O ponto é verificar se houve mudança clara em relação ao baseline e se ela acompanha o período de introdução do medicamento.

Humor e reatividade: Alguns pacientes descrevem oscilação de humor, maior sensibilidade a frustração ou sensação de estranhamento subjetivo nas primeiras semanas, enquanto outros relatam alívio secundário por conseguirem se organizar melhor. Isso pode ser confundido tanto com evolução do quadro de base quanto com impacto emocional de fracassos acumulados, conflitos familiares ou expectativas muito altas sobre o tratamento. Na sessão, ajuda observar se a reatividade está mais ligada a eventos interpessoais e narrativas habituais ou se surgiu como mudança mais abrupta no padrão recente.

Adesão e abandono silencioso: Como a resposta costuma ser gradual e alguns desconfortos iniciais podem pesar mais do que os ganhos percebidos no começo, há risco de uso irregular, esquecimento frequente ou interrupção sem elaboração prévia. O terapeuta pode notar relatos vagos de não fez diferença, oscilação difícil de explicar entre sessões ou evitamento do tema quando a medicação entra em pauta. Isso pode parecer resistência ao tratamento ou desorganização típica do TDAH, mas às vezes sinaliza que a adesão já se fragilizou por efeitos incômodos, ambivalência ou expectativa de melhora mais rápida."

O que observar em sessão

- **Atenção e rotina:** Em parte dos pacientes, a sessão começa a mostrar menos dispersão, maior capacidade de retomar o fio da conversa e alguma melhora na execução de tarefas entre sessões. Isso pode se confundir com fases de maior estrutura externa, cobrança ambiental, início de semestre, mudança de trabalho ou simples efeito de novidade por ter começado um tratamento. Vale comparar a linha de base com exemplos concretos do cotidiano e observar se a melhora aparece de modo relativamente consistente, e não apenas em dias mais organizados ou motivados.

Ativação e ansiedade: No início, alguns pacientes ficam mais acelerados, irritáveis ou corporalmente tensos, e isso pode ser vivido como piora da ansiedade ou como sensação de estar "ligado" demais. Na sessão, o terapeuta pode notar fala mais apressada, menor tolerância à frustração e dificuldade de permanecer em um tema, mas esse quadro também pode refletir estresse recente, privação de sono, cafeína, outras substâncias ou o próprio TDAH em contexto de maior demanda. A discriminação clínica depende de mapear temporalidade, intensidade e relação com o início do uso.

Sono e apetite: Alterações de sono e redução de apetite podem aparecer e, quando persistem, tendem a contaminar humor, tolerância emocional e funcionamento executivo, produzindo uma impressão de piora global. Na sessão, isso pode surgir como cansaço, irritabilidade, menor disponibilidade associativa ou relato de refeições puladas, mas o mesmo padrão também ocorre em fases de ansiedade, rotina caótica, sobrecarga acadêmica ou laboral e hábitos já prévios. O ponto é verificar se houve mudança clara em relação ao baseline e se ela acompanha o período de introdução do medicamento.

Humor e reatividade: Alguns pacientes descrevem oscilação de humor, maior sensibilidade a frustração ou sensação de estranhamento subjetivo nas primeiras semanas, enquanto outros relatam alívio secundário por conseguirem se organizar melhor. Isso pode ser confundido tanto com evolução do quadro de base quanto com impacto emocional de fracassos acumulados, conflitos familiares ou expectativas muito altas sobre o tratamento. Na sessão, ajuda observar se a reatividade está mais ligada a eventos interpessoais e narrativas habituais ou se surgiu como mudança mais abrupta no padrão recente.

Adesão e abandono silencioso: Como a resposta costuma ser gradual e alguns desconfortos iniciais podem pesar mais do que os ganhos percebidos no começo, há risco de uso irregular, esquecimento frequente ou interrupção sem elaboração prévia. O terapeuta pode notar relatos vagos de "não fez diferença", oscilação difícil de explicar entre sessões ou evitamento do tema quando a medicação entra em pauta. Isso pode parecer resistência ao tratamento ou desorganização típica do TDAH, mas às vezes sinaliza que a adesão já se fragilizou por efeitos incômodos, ambivalência ou expectativa de melhora mais rápida.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A atomoxetina é um medicamento usado sobretudo no TDAH, inclusive quando o paciente chega à terapia com queixas de desatenção, impulsividade, desorganização e repercussões acadêmicas, profissionais ou relacionais. Diferente de medicações de efeito mais imediato, a mudança costuma ser acompanhada ao longo de 2 a 6 semanas, às vezes com leitura mais nítida apenas após algumas semanas adicionais. No consultório, o ponto central é distinguir melhora gradual de autorregulação e sustentação atencional de oscilação por rotina, sono, ansiedade, expectativas iniciais ou uso irregular, além de observar se a ativação inicial ou desconfortos corporais estão interferindo na adesão.

Perguntas úteis

- "Quando você percebeu alguma mudança, ela apareceu como melhora sustentada ao longo dos dias ou só em contextos muito estruturados e com cobrança externa? , Essa sensação de estar mais acelerado ou tenso parece com a sua ansiedade habitual ou tem um componente mais corporal, como se fosse difícil desacelerar mesmo sem um motivo claro? , Seu sono e seu apetite mudaram depois do início do medicamento ou já vinham desorganizados antes por rotina, ansiedade ou estresse? , Quando você diz que está mais irritado, isso acontece principalmente diante de frustrações e conflitos como já acontecia antes, ou surgiu como um padrão mais novo e menos ligado ao contexto? , Nas semanas em que você sentiu menos efeito ou mais desconforto, o uso ficou regular ou houve dias pulados, horários muito variáveis ou vontade de parar sem comentar com ninguém?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente descreve piora importante de irritabilidade
- agitação ou ansiedade logo após o início e isso começa a comprometer rotina
- vínculo ou adesão
- pode valer alinhar com o médico assistente para contextualizar a mudança observada
- Quando alterações de sono ou apetite passam a repercutir de forma consistente no funcionamento
- no humor ou na permanência no tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente para favorecer uma leitura conjunta do quadro
- Quando a resposta segue muito incerta após 6 a 8 semanas por uso aparentemente regular
- pode valer alinhar com o médico assistente para diferenciar ausência de benefício percebido
- adesão irregular e fatores contextuais que estejam mascarando a evolução
- Quando o paciente dá sinais de abandono silencioso
- uso intermitente ou interrupção por conta própria por desconfortos iniciais
- pode valer comunicar o médico assistente porque isso dificulta a leitura clínica e aumenta a chance de desistência do tratamento
- Quando surgem humor muito expansivo
- redução importante da necessidade de sono

Amarelo: alinhar em breve

- impulsividade incomum ou sensação de estar "bom demais" fora do padrão do paciente
- pode valer contato com o médico assistente para avaliar possível mudança de estado de humor

Vermelho: tratar como urgência

- Surge ideação suicida nova ou claramente intensificada
- sobretudo nas primeiras semanas
- com piora de desesperança
- agitação ou sensação de perda de controle.: Fazer avaliação de risco na própria sessão e acionar no mesmo dia o médico assistente
- rede de apoio e emergência quando necessário
- O paciente apresenta mudança abrupta para euforia incomum
- fala muito pressionada
- redução acentuada da necessidade de sono
- impulsividade e juízo claramente rebaixado em relação ao seu padrão.: Tratar como mudança aguda de estado mental e buscar contato no mesmo dia com o médico assistente
- envolvendo rede de apoio e urgência se houver risco

Frase clínica

Na terapia, o foco com atomoxetina é separar melhora gradual de autorregulação de ativação inicial, rotina caótica e adesão irregular.

167 DEUTETRABENAZINA

Substância: Deutetrabenazina.

Nomes Comerciais: Austedo

Uso comum

- Deutetrabenazina é um modulador de movimentos involuntários, encontrado mais frequentemente em pacientes com coreia associada à doença de Huntington ou discinesia tardia. No consultório de terapia, o foco costuma recair menos sobre a indicação em si e mais sobre como a redução ou a oscilação dos movimentos repercute em autoestima, exposição social, fala, cansaço e continuidade do trabalho terapêutico. Mudanças percebidas podem surgir nas primeiras semanas após início ou ajuste, e vale atenção redobrada nesse período para diferenciar efeito do tratamento, flutuação do quadro neurológico e impacto emocional de estar mais ou menos visível socialmente.

O paciente pode relatar

- **"Movimento e presença:** A sessão pode mudar quando os movimentos involuntários diminuem, oscilam ou passam a ocupar menos o campo de atenção do paciente. Isso às vezes amplia contato visual, permanência no tema e disponibilidade para elaboração; em outros casos, a pessoa fica mais autoconsciente, como se a redução do sintoma a expusesse de outro modo. Convém não ler automaticamente essa mudança como melhora emocional global, porque ela também pode refletir variação do quadro de base, fadiga do dia ou maior esforço para controlar a apresentação corporal na sessão.

Sedação e ritmo: Alguns pacientes chegam mais lentificados, sonolentos ou com menor vivacidade, o que pode ser confundido com retraimento depressivo, desengajamento terapêutico ou piora cognitiva. O dado útil costuma ser o padrão: se a lentificação apareceu junto com o início do tratamento, se varia conforme o horário da sessão ou se contrasta com uma linha de base antes mais responsiva. Também vale considerar outras medicações sedativas, noites ruins de sono e o próprio desgaste físico de conviver com movimentos involuntários.

Humor e desesperança: Em pacientes com doença neurológica crônica, tristeza, irritabilidade e desesperança podem decorrer tanto do sofrimento com a condição quanto de mudanças recentes no tratamento ou de eventos de vida. Quando o humor piora nas semanas após uma mudança medicamentosa, a discriminação clínica fica especialmente importante, sem assumir causalidade. Na sessão, observe se houve perda de interesse mais ampla, aumento de autodepreciação, retraimento novo ou fala mais marcada por inutilidade, em vez de atribuir tudo ao peso da doença.

Fala e cognição: Pode haver momentos em que o paciente parece mais lento para responder, com fala menos espontânea ou maior dificuldade para sustentar encadeamento. Isso pode ser lido apressadamente como déficit cognitivo progressivo, mas às vezes se mistura com sonolência, ansiedade de desempenho, constrangimento com a própria fala ou variação do estado motor. Comparar com a linha de base da própria terapia ajuda mais do que comparar com um ideal de fluência.

Adesão e continuidade: Como o tratamento costuma ocorrer em contexto de condição crônica e acompanhamento especializado, adesão irregular pode aparecer menos como recusa explícita e mais como uso inconsistente, interrupções silenciosas ou ambivalência diante do benefício percebido. Na sessão, isso pode surgir quando o paciente descreve dias muito diferentes entre si, evita nomear o que mudou ou minimiza efeitos que o fazem querer abandonar o tratamento. O risco clínico é interpretar a oscilação apenas como instabilidade emocional ou progressão da doença, sem explorar a regularidade do uso."

O que observar em sessão

- **Movimento e presença:** A sessão pode mudar quando os movimentos involuntários diminuem, oscilam ou passam a ocupar menos o campo de atenção do paciente. Isso às vezes amplia contato visual, permanência no tema e disponibilidade para elaboração; em outros casos, a pessoa fica mais autoconsciente, como se a redução do sintoma a expusesse de outro modo. Convém não ler automaticamente essa mudança como melhora emocional global, porque ela também pode refletir variação do quadro de base, fadiga do dia ou maior esforço para controlar a apresentação corporal na sessão.

Sedação e ritmo: Alguns pacientes chegam mais lentificados, sonolentos ou com menor vivacidade, o que pode ser confundido com retraimento depressivo, desengajamento terapêutico ou piora cognitiva. O dado útil costuma ser o padrão: se a lentificação apareceu junto com o início do tratamento, se varia conforme o horário da sessão ou se contrasta com uma linha de base antes mais responsiva. Também vale considerar outras medicações sedativas, noites ruins de sono e o próprio desgaste físico de conviver com movimentos involuntários.

Humor e desesperança: Em pacientes com doença neurológica crônica, tristeza, irritabilidade e desesperança podem decorrer tanto do sofrimento com a condição quanto de mudanças recentes no tratamento ou de eventos de vida. Quando o humor piora nas semanas após uma mudança medicamentosa, a discriminação clínica fica especialmente importante, sem assumir causalidade. Na sessão, observe se houve perda de interesse mais ampla, aumento de autodepreciação, retraimento novo ou fala mais marcada por inutilidade, em vez de atribuir tudo ao peso da doença.

Fala e cognição: Pode haver momentos em que o paciente parece mais lento para responder, com fala menos espontânea ou maior dificuldade para sustentar encadeamento. Isso pode ser lido apressadamente como déficit cognitivo progressivo, mas às vezes se mistura com sonolência, ansiedade de desempenho, constrangimento com a própria fala ou variação do estado motor. Comparar com a linha de base da própria terapia ajuda mais do que comparar com um ideal de fluência.

Adesão e continuidade: Como o tratamento costuma ocorrer em contexto de condição crônica e acompanhamento especializado, adesão irregular pode aparecer menos como recusa explícita e mais como uso inconsistente, interrupções silenciosas ou ambivalência diante do benefício percebido. Na sessão, isso pode surgir quando o paciente descreve dias muito diferentes entre si, evita nomear o que mudou ou minimiza efeitos que o fazem querer abandonar o tratamento. O risco clínico é interpretar a oscilação apenas como instabilidade emocional ou progressão da doença, sem explorar a regularidade do uso.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Deutetrabenazina é um modulador de movimentos involuntários, encontrado mais frequentemente em pacientes com coreia associada à doença de Huntington ou discinesia tardia. No consultório de terapia, o foco costuma recair menos sobre a indicação em si e mais sobre como a redução ou a oscilação dos movimentos repercute em autoestima, exposição social, fala, cansaço e continuidade do trabalho terapêutico. Mudanças percebidas podem surgir nas primeiras semanas após início ou ajuste, e vale atenção redobrada nesse período para diferenciar efeito do tratamento, flutuação do quadro neurológico e impacto emocional de estar mais ou menos visível socialmente.

Perguntas úteis

- "Quando você se percebe mais lento ou sonolento, isso vem junto de tristeza e desânimo ou parece mais um corpo que não acompanha o que você quer fazer? , Nos dias em que os movimentos incomodam menos, você se sente emocionalmente melhor de modo mais amplo ou apenas menos exposto e menos constrangido? , Essa mudança na sua disposição apareceu de forma contínua desde que algo mudou no tratamento, ou oscila bastante de um dia para outro? , Quando sua fala ou seu raciocínio parecem mais travados, você sente a mente confusa, sono, ansiedade por estar sendo observado ou esforço para controlar o corpo? , Teve algum período recente em que você deixou de tomar, tomou de modo irregular ou pensou em parar porque não estava gostando de como estava se sentindo? , Quando o humor piora, isso vem principalmente do impacto da doença e da rotina de tratamento ou você percebe uma mudança mais abrupta no seu jeito de se sentir?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- lentificado ou menos responsivo do que sua linha de base
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer se há relação temporal com o tratamento ou com outras medicações em uso
- Quando surge piora de humor
- desesperança ou retraimento nas semanas após início ou mudança recente do tratamento
- pode valer comunicação com o médico para avaliação conjunta da evolução clínica
- Quando a oscilação entre dias muito diferentes levanta suspeita de uso irregular
- interrupção silenciosa ou ambivalência importante com o tratamento
- pode valer alinhar com o médico para contextualizar a adesão observada em sessão
- Quando o paciente relata benefício motor parcial
- mas às custas de cansaço
- embotamento ou prejuízo funcional que ameaça a continuidade do tratamento
- pode valer comunicar o médico assistente para situar o impacto subjetivo e funcional
- Quando aparecem piora importante da fala
- da responsividade ou da organização do pensamento em relação ao padrão habitual

Amarelo: alinhar em breve

- pode valer contato com o médico para diferenciar progressão do quadro de base
- intercorrência clínica e possível efeito do tratamento

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente expressa ideação suicida atual
- intenção
- planejamento ou sensação de que não consegue se manter seguro.: Fazer manejo de risco no mesmo dia
- acionar rede de apoio e contato médico imediato
- recorrendo à emergência quando necessário
- Surge rebaixamento importante do nível de consciência
- confusão acentuada ou dificuldade marcante para se manter acordado e orientado durante a sessão.: Interromper o trabalho psicoterápico como de costume e buscar avaliação médica imediata
- com apoio de acompanhante ou emergência se necessário

Frase clínica

O ponto central é diferenciar mudança motora útil de lentificação, sofrimento emocional e oscilação de adesão em um contexto neurológico crônico.

168 RILUZOL

Substância: Riluzol.

Nomes Comerciais: Riluzol, Tekzor

Uso comum

- Riluzol é um medicamento usado sobretudo na esclerose lateral amiotrófica, contexto pouco frequente no consultório geral de psicoterapia. Aqui, o foco costuma ser menos um efeito subjetivo específico do fármaco e mais como o paciente em tratamento contínuo para uma doença neurológica progressiva chega à sessão: fadiga, lentificação, fala mais difícil, oscilação entre esperança e luto antecipatório, além da carga prática do acompanhamento médico. Ao longo de semanas e meses, vale acompanhar mudanças no ritmo da comunicação, na autonomia e na tolerância emocional ao avanço da condição, sem atribuir automaticamente essas mudanças ao medicamento.

O paciente pode relatar

- "Carga do tratamento:** O tratamento costuma entrar na sessão como rotina exigente, consultas frequentes, exames, organização doméstica e necessidade crescente de ajuda. Isso pode aparecer como cansaço psíquico, irritabilidade com a agenda médica ou sensação de vida reduzida ao papel de paciente. Na leitura clínica, convém diferenciar o peso do tratamento e da progressão da doença de um suposto efeito direto do medicamento, especialmente quando a sobrecarga aumentou nas últimas semanas.

Funcionalidade e identidade: Mudanças na fala, na mobilidade, na escrita ou na autonomia podem alterar profundamente a forma como o paciente se percebe e se apresenta no vínculo terapêutico. Em sessão, às vezes o sofrimento aparece menos como tristeza nomeada e mais como retraimento, vergonha, pressa para terminar frases ou recusa em depender de terceiros. Vale observar se a oscilação acompanha perdas funcionais concretas e situações de exposição, em vez de concluir de saída que se trata de humor deprimido primário ou efeito medicamentoso.

Sustentação do trabalho terapêutico: Com doença neurológica progressiva, o enquadre pode precisar acomodar mais pausas, comunicação mais lenta e maior variabilidade de energia entre sessões. O que parece desinteresse, empobrecimento associativo ou afastamento do vínculo pode, em parte, refletir fadiga, esforço para falar ou frustração com limitações recentes. A discriminação clínica fica mais precisa quando se compara o padrão atual com a baseline do paciente e com o momento da doença, em vez de ler toda mudança como resistência ou piora psiquiátrica."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento costuma entrar na sessão como rotina exigente, consultas frequentes, exames, organização doméstica e necessidade crescente de ajuda. Isso pode aparecer como cansaço psíquico, irritabilidade com a agenda médica ou sensação de vida reduzida ao papel de paciente. Na leitura clínica, convém diferenciar o peso do tratamento e da progressão da doença de um suposto efeito direto do medicamento, especialmente quando a sobrecarga aumentou nas últimas semanas.

Funcionalidade e identidade: Mudanças na fala, na mobilidade, na escrita ou na autonomia podem alterar profundamente a forma como o paciente se percebe e se apresenta no vínculo terapêutico. Em sessão, às vezes o sofrimento aparece menos como tristeza nomeada e mais como retraimento, vergonha, pressa para terminar frases ou recusa em depender de terceiros. Vale observar se a oscilação acompanha perdas funcionais concretas e situações de exposição, em vez de concluir de saída que se trata de humor deprimido primário ou efeito medicamentoso.

Sustentação do trabalho terapêutico: Com doença neurológica progressiva, o enquadre pode precisar acomodar mais pausas, comunicação mais lenta e maior variabilidade de energia entre sessões. O que parece desinteresse, empobrecimento associativo ou afastamento do vínculo pode, em parte, refletir fadiga, esforço para falar ou frustração com limitações recentes. A discriminação clínica fica mais precisa quando se compara o padrão atual com a baseline do paciente e com o momento da doença, em vez de ler toda mudança como resistência ou piora psiquiátrica.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Riluzol é um medicamento usado sobretudo na esclerose lateral amiotrófica, contexto pouco frequente no consultório geral de psicoterapia. Aqui, o foco costuma ser menos um efeito subjetivo específico do fármaco e mais como o paciente em tratamento contínuo para uma doença neurológica progressiva chega à sessão: fadiga, lentificação, fala mais difícil, oscilação entre esperança e luto antecipatório, além da carga prática do acompanhamento médico. Ao longo de semanas e meses, vale acompanhar mudanças no ritmo da comunicação, na autonomia e na tolerância emocional ao avanço da condição, sem atribuir automaticamente essas mudanças ao medicamento.

Perguntas úteis

- "Quando você se cala ou encurta as respostas aqui, isso vem mais de cansaço para sustentar a conversa, de dificuldade para se expressar ou de vontade de se afastar do tema? , Nas últimas semanas, o que mais pesou no seu humor: mudanças concretas no corpo e na autonomia, preocupações com o futuro ou algo que você percebe como diferente sem relação clara com esses fatores? , Quando você evita encontros, tarefas ou conversas, isso acontece mais por limitação física e fadiga, por vergonha de como está sendo visto ou por perda geral de interesse? , O que mudou primeiro para você: a sensação de desânimo ou as dificuldades práticas do dia a dia ligadas ao tratamento e à doença? , Quando a sessão fica mais difícil, isso varia conforme seu nível de energia no dia ou conforme os assuntos tocam perdas e dependência?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente mostra piora funcional perceptível em poucas semanas
- com impacto claro na comunicação ou na capacidade de comparecer e se organizar
- pode valer alinhar com o médico assistente para atualização do quadro e do plano de acompanhamento
- Quando surgem tristeza persistente
- desesperança ou retraimento importantes que excedem o esperado diante das perdas recentes
- pode valer comunicar o médico para discriminar sofrimento adaptativo
- episódio depressivo e necessidade de avaliação clínica mais ampla
- Quando a fadiga
- a lentificação ou a dificuldade de sustentar a sessão aumentam a ponto de comprometer adesão ao tratamento e presença em consultas
- pode valer alinhar com a equipe médica para manejo coordenado da funcionalidade
- Quando o paciente relata que deixou de usar a medicação por conta própria
- de modo silencioso ou ambivalente
- pode valer comunicar o médico assistente para que a adesão e o contexto da interrupção sejam avaliados diretamente com ele

Vermelho: tratar como urgência

- Aparecem ideação suicida atual com intenção
- plano ou sensação de que não consegue se manter seguro diante da progressão da doença.: Fazer manejo imediato de risco
- acionar rede de apoio e contato médico no mesmo dia
- recorrendo à emergência quando necessário
- Durante a sessão
- surge piora abrupta importante da respiração
- incapacidade de falar frases curtas como habitual ou exaustão extrema fora do padrão do paciente.: Interromper o trabalho psicoterápico e acionar avaliação médica urgente ou emergência
- conforme a gravidade e os recursos disponíveis

Frase clínica

Com riluzol, o foco terapêutico costuma recair menos no fármaco e mais na experiência psíquica de viver uma doença neurológica progressiva.

169 SATRALIZUMABE

Substância: Satralizumabe.

Nomes Comerciais: Enspr yng

Uso comum

- Satralizumabe é um biológico usado em tratamento contínuo de condição neurológica autoimune rara, mais frequentemente em pacientes que convivem com surtos, incerteza clínica e acompanhamento médico prolongado. No consultório de terapia, o foco tende a recair menos sobre efeitos subjetivos específicos do fármaco e mais sobre como o tratamento se insere na vida do paciente ao longo de semanas e meses: expectativa de estabilidade, medo de nova piora, impacto funcional e relação com a equipe. Vale acompanhar mudanças no padrão da sessão após início ou retomada do tratamento, sem supor causalidade direta, e observar se oscilações emocionais acompanham eventos de saúde, rotina de cuidados ou adesão irregular.

O paciente pode relatar

- **"Carga do tratamento:** O tratamento pode aparecer como organizador da rotina, com consultas, exames, aplicação, planejamento e vigilância constante de sinais corporais. Em sessão, isso às vezes se traduz em fala mais centrada no corpo, menor disponibilidade associativa ou sensação de vida em suspenso. Pode confundir a leitura o fato de parte desse estreitamento vir da própria condição de base, de experiências prévias de surto ou de fases de maior exigência médica, e não necessariamente do medicamento em si.

Sofrimento e incerteza: Muitos pacientes chegam atravessados por medo de recaída, hipervigilância a sensações físicas e dificuldade de confiar em períodos de estabilidade. O terapeuta pode notar oscilação entre esperança e catastrofização, além de dificuldade de diferenciar sintoma atual, memória corporal de crises anteriores e ansiedade antecipatória. Também entram como confundidores notícias médicas recentes, mudanças funcionais reais e o impacto cumulativo de viver com uma doença rara.

Funcionalidade e identidade: Quando há tratamento contínuo, questões de autonomia, produtividade e identidade costumam ganhar relevo: o paciente pode se perceber mais como alguém em tratamento do que como alguém vivendo a própria vida. Na sessão, isso pode aparecer como retração de projetos, redefinição de papéis familiares ou vergonha por limitações flutuantes. Vale não reduzir essas mudanças a desânimo inespecífico, porque podem refletir adaptação à doença, luto por perdas funcionais ou tentativa de prevenir nova desorganização."

O que observar em sessão

- **Carga do tratamento:** O tratamento pode aparecer como organizador da rotina, com consultas, exames, aplicação, planejamento e vigilância constante de sinais corporais. Em sessão, isso às vezes se traduz em fala mais centrada no corpo, menor disponibilidade associativa ou sensação de vida em suspenso. Pode confundir a leitura o fato de parte desse estreitamento vir da própria condição de base, de experiências prévias de surto ou de fases de maior exigência médica, e não necessariamente do medicamento em si.

Sofrimento e incerteza: Muitos pacientes chegam atravessados por medo de recaída, hipervigilância a sensações físicas e dificuldade de confiar em períodos de estabilidade. O terapeuta pode notar oscilação entre esperança e catastrofização, além de dificuldade de diferenciar sintoma atual, memória corporal de crises anteriores e ansiedade antecipatória. Também entram como confundidores notícias médicas recentes, mudanças funcionais reais e o impacto cumulativo de viver com uma doença rara.

Funcionalidade e identidade: Quando há tratamento contínuo, questões de autonomia, produtividade e identidade costumam ganhar relevo: o paciente pode se perceber mais como alguém em tratamento do que como alguém vivendo a própria vida. Na sessão, isso pode aparecer como retração de projetos, redefinição de papéis familiares ou vergonha por limitações flutuantes. Vale não reduzir essas mudanças a desânimo inespecífico, porque podem refletir adaptação à doença, luto por perdas funcionais ou tentativa de prevenir nova desorganização.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Satralizumabe é um biológico usado em tratamento contínuo de condição neurológica autoimune rara, mais frequentemente em pacientes que convivem com surtos, incerteza clínica e acompanhamento médico prolongado. No consultório de terapia, o foco tende a recair menos sobre efeitos subjetivos específicos do fármaco e mais sobre como o tratamento se insere na vida do paciente ao longo de semanas e meses: expectativa de estabilidade, medo de nova piora, impacto funcional e relação com a equipe. Vale acompanhar mudanças no padrão da sessão após início ou retomada do tratamento, sem supor causalidade direta, e observar se oscilações emocionais acompanham eventos de saúde, rotina de cuidados ou adesão irregular.

Perguntas úteis

- "Quando você percebe uma piora no seu estado emocional, ela costuma vir junto de algum sinal físico, consulta, exame ou notícia sobre a doença, ou aparece mais solta desses contextos? , Nos períodos em que você se sente mais travado ou recolhido, isso parece mais cansaço do tratamento e da rotina médica, medo de piorar, ou perda de interesse que se espalha para tudo? , Quando você evita fazer planos, a sensação é de prudência diante da incerteza clínica ou de desistência mais ampla da vida cotidiana? , Desde que esse tratamento entrou na sua rotina, o que mudou mais na sessão: seu nível de esperança, sua vigilância com o corpo ou sua confiança para retomar atividades?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a relatar interrupções
- adiamentos frequentes ou dificuldade persistente de sustentar o tratamento
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o impacto clínico e o contexto da adesão
- Quando surgem mudanças funcionais importantes
- novos sintomas físicos referidos ou piora clínica associada a intenso sofrimento psíquico
- pode valer comunicar o médico para integrar leitura emocional e curso da condição de base
- Quando a sessão fica dominada por medo de recaída
- checagem corporal incessante ou interpretação catastrófica de qualquer sensação física após mudança recente no tratamento
- pode valer alinhar com a equipe para reduzir desencontros de leitura
- Quando o paciente relata sensação de abandono
- desconfiança marcada ou ruptura iminente com a equipe que conduz o caso
- pode valer comunicação para preservar continuidade de cuidado

Vermelho: tratar como urgência

- O paciente chega com piora física importante referida
- muito abatido
- confuso sobre o que está acontecendo e sem retaguarda organizada para o mesmo dia.: Interromper o foco interpretativo
- priorizar segurança imediata e acionar médico assistente
- rede de apoio ou serviço de urgência conforme a gravidade apresentada
- Em meio ao curso da doença ou a uma piora recente
- emerge ideação suicida atual com intenção
- planejamento ou sensação de não conseguir se manter seguro.: Manejar como urgência no mesmo dia
- com avaliação de risco
- acionamento de rede de apoio e contato com emergência e médico assistente quando necessário

Frase clínica

O centro da escuta aqui costuma ser menos o biológico em si e mais o peso psíquico de viver em tratamento contínuo para uma condição neurológica rara.

170 CLORIDRATO DE HIDROXIZINA

Substância: Cloridrato de Hidroxizina.

Nomes Comerciais: Hixizine, Cloridrato de Hidroxizine, Droxy, Cloridrato de Hidroxizina

Uso comum

- A hidroxizina é um anti-histamínico sedativo que pode aparecer no consultório quando o paciente a usa para ansiedade, insônia, prurido ou quadros alérgicos. Na terapia, o mais útil costuma ser acompanhar o que muda nas primeiras horas e nos primeiros dias após o início ou uso mais regular: sonolência, lentificação, menor reatividade ansiosa e, em alguns casos, sensação de “apagamento” ou dificuldade de concentração. O ponto central é diferenciar alívio de hiperativação e insônia de uma sedação que empobrece presença psíquica, além de notar uso irregular, sobretudo quando o paciente passa a tomar “conforme necessário” em momentos de maior tensão.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter mais lentificação, bocejos, fala menos espontânea e menor acesso associativo, especialmente quando a medicação foi usada pouco antes do atendimento ou em dias consecutivos. Isso pode ser confundido com melhora da ansiedade, cansaço acumulado, privação de sono ou rebaixamento depressivo. Vale observar se a redução da angústia vem acompanhada de preservação de presença e elaboração, ou se o paciente parece apenas mais amortecido e com menor capacidade de sustentar o trabalho psíquico.

Ansiedade aguda: Quando a hidroxizina entra em cena por ansiedade, o paciente pode descrever menos urgência corporal, menos tensão e mais facilidade para interromper escaladas de inquietação. Na sessão, isso às vezes se parece com ganho real de regulação; em outras, a ansiedade de base permanece, mas menos visível porque o corpo está mais desacelerado. A discriminação clínica depende de notar se houve mudança também na antecipação catastrófica, na evitação e na capacidade de pensar sobre o afeto, e não apenas no nível de agitação.

Sono e vigília: Muitos pacientes a associam ao sono, e isso pode repercutir no consultório como sonolência diurna, sensação de "ressaca" ao acordar ou, ao contrário, alívio importante após noites antes muito fragmentadas. O que aparece na sessão pode ser confundido tanto com insônia prévia quanto com exaustão por eventos de vida, uso de álcool, outras medicações sedativas ou rotina desorganizada. A linha de base ajuda: se o paciente dorme melhor mas chega mais presente e funcional, a leitura é diferente de quando o sono melhora às custas de embotamento persistente no dia seguinte.

Cognição na sessão: Pode surgir queixa de atenção mais frouxa, memória imediata menos nítida e dificuldade de acompanhar raciocínios mais longos, algo que o terapeuta percebe como perda de fio, respostas mais concretas ou menor capacidade reflexiva. Esse quadro pode ser lido apressadamente como resistência, desinteresse ou piora ansioso-depressiva. Convém situar a oscilação no tempo: se aparece perto do uso, em dias específicos ou junto de outras substâncias sedativas, a hipótese de efeito medicamentoso ganha força sem excluir sofrimento psíquico concomitante.

Uso irregular: Como costuma ser usada também de forma intermitente, a sessão pode trazer um padrão de dias muito diferentes entre si: em alguns, o paciente chega mais contido e sonolento; em outros, mais ansioso e reativo. Sem perguntar pelo contexto de uso, isso pode parecer instabilidade emocional primária ou oscilação do quadro. O ponto clínico é mapear se a medicação entra como recurso em crises, se o paciente evita usar por receio de ficar "apagado" ou se abandonou silenciosamente por incômodo com a sedação."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Em parte dos pacientes, a sessão passa a ter mais lentificação, bocejos, fala menos espontânea e menor acesso associativo, especialmente quando a medicação foi usada pouco antes do atendimento ou em dias consecutivos. Isso pode ser confundido com melhora da ansiedade, cansaço acumulado, privação de sono ou rebaixamento depressivo. Vale observar se a redução da angústia vem acompanhada de preservação de presença e elaboração, ou se o paciente parece apenas mais amortecido e com menor capacidade de sustentar o trabalho psíquico.

Ansiedade aguda: Quando a hidroxizina entra em cena por ansiedade, o paciente pode descrever menos urgência corporal, menos tensão e mais facilidade para interromper escaladas de inquietação. Na sessão, isso às vezes se parece com ganho real de regulação; em outras, a ansiedade de base permanece, mas menos visível porque o corpo está mais desacelerado. A discriminação clínica depende de notar se houve mudança também na antecipação catastrófica, na evitação e na capacidade de pensar sobre o afeto, e não apenas no nível de agitação.

Sono e vigília: Muitos pacientes a associam ao sono, e isso pode repercutir no consultório como sonolência diurna, sensação de “ressaca” ao acordar ou, ao contrário, alívio importante após noites antes muito fragmentadas. O que aparece na sessão pode ser confundido tanto com insônia prévia quanto com exaustão por eventos de vida, uso de álcool, outras medicações sedativas ou rotina desorganizada. A linha de base ajuda: se o paciente dorme melhor mas chega mais presente e funcional, a leitura é diferente de quando o sono melhora às custas de embotamento persistente no dia seguinte.

Cognição na sessão: Pode surgir queixa de atenção mais frouxa, memória imediata menos nítida e dificuldade de acompanhar raciocínios mais longos, algo que o terapeuta percebe como perda de fio, respostas mais concretas ou menor capacidade reflexiva. Esse quadro pode ser lido apressadamente como resistência, desinteresse ou piora ansioso-depressiva. Convém situar a oscilação no tempo: se aparece perto do uso, em dias específicos ou junto de outras substâncias sedativas, a hipótese de efeito medicamentoso ganha força sem excluir sofrimento psíquico concomitante.

Uso irregular: Como costuma ser usada também de forma intermitente, a sessão pode trazer um padrão de dias muito diferentes entre si: em alguns, o paciente chega mais contido e sonolento; em outros, mais ansioso e reativo. Sem perguntar pelo contexto de uso, isso pode parecer instabilidade emocional primária ou oscilação do quadro. O ponto clínico é mapear se a medicação entra como recurso em crises, se o paciente evita usar por receio de ficar “apagado” ou se abandonou silenciosamente por incômodo com a sedação.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A hidroxizina é um anti-histamínico sedativo que pode aparecer no consultório quando o paciente a usa para ansiedade, insônia, prurido ou quadros alérgicos. Na terapia, o mais útil costuma ser acompanhar o que muda nas primeiras horas e nos primeiros dias após o início ou uso mais regular: sonolência, lentificação, menor reatividade ansiosa e, em alguns casos, sensação de “apagamento” ou dificuldade de concentração. O ponto central é diferenciar alívio de hiperativação e insônia de uma sedação que empobrece presença psíquica, além de notar uso irregular, sobretudo quando o paciente passa a tomar “conforme necessário” em momentos de maior tensão.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais calmo, isso vem com mais clareza para pensar e falar sobre o que sente ou vem mais como sonolência e desligamento? , Nos dias em que chega mais lento ou com mais sono, isso costuma acontecer depois de usar a medicação, depois de dormir mal, ou em momentos de maior esgotamento? , Quando a ansiedade diminui, você também percebe menos preocupação e menos evitação, ou principalmente menos agitação no corpo? , Essa dificuldade de concentração aparece de modo mais constante ao longo da semana ou em períodos mais próximos de quando você toma a medicação? , Você tem usado de forma parecida todos os dias ou mais em momentos de crise, quando sente que não está dando conta? , Quando evita tomar, o que pesa mais: sentir que não precisa, receio de ficar sedado, ou alguma outra experiência desagradável?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- chegar muito sonolento ou relata prejuízo consistente para dirigir
- trabalhar ou sustentar a rotina após o uso
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar impacto funcional e tolerabilidade
- Quando a ansiedade parece apenas mascarada por sedação
- sem ganho de elaboração
- e o paciente começa a usar repetidamente em situações de tensão
- pode valer comunicar para contextualizar o padrão clínico observado
- Quando há abandono silencioso ou uso muito irregular por incômodo com sonolência
- lentificação ou sensação de apagamento
- pode valer alinhar com o médico para reduzir risco de manejo errático por conta própria
- Quando surgem confusão mais marcada
- desorganização incomum ou rebaixamento importante de responsividade temporalmente associado ao uso
- pode valer contato com o médico para avaliação clínica mais rápida

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente aparece muito confuso
- dificilmente sustentando contato
- com rebaixamento acentuado de alerta ou comportamento que sugere risco imediato para se manter em segurança.: Interromper o trabalho interpretativo
- avaliar segurança imediata e acionar médico
- rede de apoio ou emergência conforme a gravidade do quadro
- Surge ideação suicida com intenção
- plano ou perda importante de controle
- independentemente de possível relação com a medicação.: Manejar como urgência clínica no mesmo dia
- acionando rede de apoio
- médico assistente e emergência quando necessário

Frase clínica

O foco clínico é distinguir redução da ansiedade de sedação que empobrece presença psíquica, cognição e funcionamento.

171 CLORIDRATO DE PROMETAZINA

Substância: Cloridrato de Prometazina.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Prometazina, Pamergan, Profergan, Promergan, Prometazol, Lisador, Fenergan

Uso comum

- A prometazina é um anti-histamínico sedativo, usado em geral para alergias, náusea, prurido e, em alguns contextos, como medicação para induzir sono. No consultório de terapia, costuma aparecer mais pelo impacto subjetivo de sonolência, lentificação, boca seca e redução da disposição do que pelo motivo original da prescrição. Esses efeitos podem surgir já nas primeiras tomadas e variar conforme horário de uso e uso intermitente. O ponto central na sessão é diferenciar sedação medicamentosa de piora depressiva, exaustão por rotina, privação de sono ou uso concomitante de outras substâncias sedativas.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, menor iniciativa associativa e dificuldade de sustentar o fio da conversa podem aparecer de modo evidente na sessão, às vezes com aspecto de "apagamento" que o paciente descreve como cansaço ou moleza. Isso pode ser confundido com rebaixamento depressivo, esgotamento por sobrecarga ou noites mal dormidas. Vale observar se há relação temporal com o uso, com determinados horários do dia ou com uso apenas em alguns dias, porque a oscilação ajuda a separar efeito da medicação de uma mudança mais estável do quadro psíquico.

Sono e vigília: Alguns pacientes chegam relatando que dormem mais facilmente, mas acordam pesados, com dificuldade para engatar o dia ou com sensação de sono não reparador. Em sessão, isso pode aparecer como bocejos, atenção flutuante e menor acesso afetivo, o que pode ser lido apressadamente como resistência, desinvestimento ou retraimento depressivo. A discriminação clínica melhora quando se compara o padrão de sono antes e depois do início do uso e quando se investiga se a lentificação se concentra pela manhã ou persiste ao longo do dia.

Cognição prática: Pode haver queixa de cabeça "enevoada", esquecimento banal, dificuldade de concentração e menor agilidade para organizar pensamento e tarefas. No setting, isso às vezes se traduz em perda do encadeamento, necessidade de repetir perguntas ou menor capacidade de elaboração, o que pode ser confundido com ansiedade, estresse ou piora do quadro de base. Também convém considerar outras medicações sedativas, álcool e privação de sono, porque a combinação desses fatores costuma pesar mais do que um único elemento isolado.

Tolerabilidade corporal: Boca seca, constipação, visão mais embaçada e sensação corporal de peso podem entrar no relato como incômodos aparentemente "menores", mas suficientes para alterar humor, disposição e adesão silenciosa. Na sessão, o paciente pode parecer mais irritadiço, menos paciente ou mais autocentrado no desconforto físico, sem que isso represente necessariamente agravamento psicopatológico. Quando esses sinais surgem logo após o início ou reaparecem em dias de uso, a leitura tende a ficar mais clara do que quando se atribui tudo ao estado emocional.

Adesão irregular: Como a prometazina muitas vezes é usada de forma intermitente ou conforme necessidade, o paciente pode alternar dias de maior sedação com dias de maior alerta sem perceber essa relação. Isso pode produzir uma impressão enganosa de instabilidade emocional, oscilação de motivação ou inconsistência no trabalho terapêutico. Vale mapear com precisão quando tomou, em que contexto e como estava nas 12 a 24 horas seguintes, porque a irregularidade de uso frequentemente explica mudanças abruptas no padrão da sessão."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, menor iniciativa associativa e dificuldade de sustentar o fio da conversa podem aparecer de modo evidente na sessão, às vezes com aspecto de “apagamento” que o paciente descreve como cansaço ou moleza. Isso pode ser confundido com rebaixamento depressivo, esgotamento por sobrecarga ou noites mal dormidas. Vale observar se há relação temporal com o uso, com determinados horários do dia ou com uso apenas em alguns dias, porque a oscilação ajuda a separar efeito da medicação de uma mudança mais estável do quadro psíquico.

Sono e vigília: Alguns pacientes chegam relatando que dormem mais facilmente, mas acordam pesados, com dificuldade para engatar o dia ou com sensação de sono não reparador. Em sessão, isso pode aparecer como bocejos, atenção flutuante e menor acesso afetivo, o que pode ser lido apressadamente como resistência, desinvestimento ou retraimento depressivo. A discriminação clínica melhora quando se compara o padrão de sono antes e depois do início do uso e quando se investiga se a lentificação se concentra pela manhã ou persiste ao longo do dia.

Cognição prática: Pode haver queixa de cabeça “enevoada”, esquecimento banal, dificuldade de concentração e menor agilidade para organizar pensamento e tarefas. No setting, isso às vezes se traduz em perda do encadeamento, necessidade de repetir perguntas ou menor capacidade de elaboração, o que pode ser confundido com ansiedade, estresse ou piora do quadro de base. Também convém considerar outras medicações sedativas, álcool e privação de sono, porque a combinação desses fatores costuma pesar mais do que um único elemento isolado.

Tolerabilidade corporal: Boca seca, constipação, visão mais embaçada e sensação corporal de peso podem entrar no relato como incômodos aparentemente “menores”, mas suficientes para alterar humor, disposição e adesão silenciosa. Na sessão, o paciente pode parecer mais irritadiço, menos paciente ou mais autocentrado no desconforto físico, sem que isso represente necessariamente agravamento psicopatológico. Quando esses sinais surgem logo após o início ou reaparecem em dias de uso, a leitura tende a ficar mais clara do que quando se atribui tudo ao estado emocional.

Adesão irregular: Como a prometazina muitas vezes é usada de forma intermitente ou conforme necessidade, o paciente pode alternar dias de maior sedação com dias de maior alerta sem perceber essa relação. Isso pode produzir uma impressão enganosa de instabilidade emocional, oscilação de motivação ou inconsistência no trabalho terapêutico. Vale mapear com precisão quando tomou, em que contexto e como estava nas 12 a 24 horas seguintes, porque a irregularidade de uso frequentemente explica mudanças abruptas no padrão da sessão.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A prometazina é um anti-histamínico sedativo, usado em geral para alergias, náusea, prurido e, em alguns contextos, como medicação para induzir sono. No consultório de terapia, costuma aparecer mais pelo impacto subjetivo de sonolência, lentificação, boca seca e redução da disposição do que pelo motivo original da prescrição. Esses efeitos podem surgir já nas primeiras tomadas e variar conforme horário de uso e uso intermitente. O ponto central na sessão é diferenciar sedação medicamentosa de piora depressiva, exaustão por rotina, privação de sono ou uso concomitante de outras substâncias sedativas.

Perguntas úteis

- "Nos dias em que você se sente mais lento ou sonolento, isso costuma acontecer depois de tomar a medicação ou aparece do mesmo jeito mesmo quando não toma? , Quando você acorda mais pesado, a sensação é de tristeza e desânimo ou mais de corpo sedado e mente lenta? , Essa dificuldade de concentração vem junto com preocupação acelerada e tensão, ou com uma espécie de torpor e sonolência? , Você percebe diferença no seu funcionamento entre manhã, tarde e noite, especialmente nos dias em que usa essa medicação? , Quando você deixa de tomar em um dia em que costumava usar, você se sente mais parecido com seu padrão habitual ou surgem outros desconfortos que mudam a leitura?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- lentificado ou com prejuízo claro de atenção
- pode valer alinhar com o médico assistente para esclarecer o peso funcional desse efeito no cotidiano
- Quando surgem incômodos físicos persistentes
- como boca muito seca
- constipação importante ou visão turva
- e isso começa a afetar adesão ou bem-estar
- pode valer comunicar para contextualizar o impacto clínico observado
- Quando o uso é irregular e a sessão revela oscilação marcante entre dias de sedação e dias de maior alerta
- pode valer alinhar com o médico para evitar leituras equivocadas sobre piora psiquiátrica
- Quando o paciente considera interromper por conta própria porque se sente excessivamente apagado ou improdutivo
- pode valer comunicar o médico assistente pela chance de abandono silencioso do tratamento
- Quando há associação com álcool ou outras medicações sedativas e o paciente descreve rebaixamento importante de vigília
- pode valer contato com o médico pela soma de efeitos no funcionamento

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão
- há rebaixamento importante de vigília
- dificuldade de se manter acordado
- confusão ou fala muito desconexa após uso recente ou associação com álcool/outras substâncias.: Interromper a exploração psicoterápica
- avaliar segurança imediata e acionar médico
- rede de apoio ou emergência conforme o grau de comprometimento
- Aparecem agitação intensa
- inquietação incomum
- desorientação ou mudança abrupta do estado mental acompanhada de mal-estar físico importante.: Tratar como alteração aguda do estado clínico
- buscar avaliação médica no mesmo dia e acionar emergência se houver piora ou risco

Frase clínica

O foco clínico costuma ser separar sedação e lentificação por prometazina de depressão, exaustão ou oscilação ligada ao uso intermitente.

172 DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA

Substância: Dicloridrato de Hidroxizina.

Nomes Comerciais: Dicloridrato de Hidroxizina, Hixilerg, Hoxidrin, Cloridrato de Hidroxizina, Hidroalerg, Pruri-Gran

Uso comum

- O dicloridrato de hidroxizina é um anti-histamínico com uso frequente quando há prurido, quadros alérgicos e, em alguns contextos, para reduzir tensão e facilitar o sono. No consultório, tende a aparecer mais pelo impacto subjetivo de sedação, lentificação e sonolência do que por mudanças emocionais específicas. Esses efeitos podem surgir já nas primeiras tomadas ou nos primeiros dias e variar bastante conforme horário de uso, sensibilidade individual e associação com outras medicações ou álcool. O ponto central na sessão é diferenciar sonolência medicamentosa de piora depressiva, apatia, privação de sono ou exaustão ligada ao contexto de vida.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, bocejos, dificuldade de sustentar atenção e menor vivacidade na sessão podem aparecer logo no início do uso ou após retomadas irregulares. Em alguns pacientes isso é vivido como alívio da agitação; em outros, como embotamento incômodo ou queda de rendimento. A leitura pode se confundir com depressão, esgotamento, noites mal dormidas, uso de álcool ou outras medicações sedativas. Vale comparar com a linha de base e com o horário em que o paciente costuma tomar a medicação.

Sono e vigília: Quando usada à noite, a hidroxizina pode coincidir com melhora para iniciar o sono, mas também com despertar mais difícil, sensação de ressaca ao acordar ou sonolência residual na sessão do dia seguinte. Se o paciente relata dormir mais, isso não equivale necessariamente a sono reparador. Também pode haver confusão com reorganização recente da rotina, privação crônica de sono, ansiedade noturna em remissão parcial ou uso concomitante de cafeína e outros sedativos. O terapeuta ganha mais clareza ao observar se a mudança se concentra no início da noite, na manhã seguinte ou ao longo de todo o dia.

Ansiedade observável: Parte dos pacientes chega menos reativa, menos acelerada e com menor urgência corporal, o que pode ser lido como redução de ansiedade; em outros, a sedação apenas encobre a expressão da angústia sem ampliar elaboração. Se a pessoa parece mais calma, vale discriminar se houve de fato diminuição de ruminação, antecipação catastrófica e evitação, ou se há apenas cansaço e menor energia para reagir. Eventos de vida, melhora espontânea do quadro e expectativa positiva com o tratamento também podem produzir uma sessão aparentemente mais tranquila. O foco é distinguir contenção sintomática de mudança clínica mais ampla.

Cognição funcional: Alguns pacientes descrevem cabeça pesada, raciocínio mais lento, lapsos atencionais ou dificuldade para acompanhar leituras, trabalho e direção. Na sessão, isso pode surgir como perda do fio, necessidade de repetição ou menor capacidade associativa, sobretudo se a tomada foi recente. Esse padrão pode ser confundido com ansiedade elevada, sobrecarga, privação de sono, uso de substâncias ou sofrimento clínico de base. A utilidade clínica está em mapear se a oscilação cognitiva acompanha o uso e se está interferindo na funcionalidade cotidiana.

Adesão prática: Como a hidroxizina costuma ser percebida rapidamente no corpo, o paciente às vezes passa a usar de modo irregular conforme necessidade percebida, evitando em dias de trabalho, dirigindo ou quando teme ficar sonolento. Esse padrão pode gerar relatos inconsistentes: em uma semana parece muito útil, em outra parece ineficaz ou excessiva. A oscilação pode refletir não só o medicamento, mas também horários variáveis, associação com álcool, esquecimento ou uso apenas em momentos de maior desconforto. Na terapia, vale observar se a adesão real difere da adesão presumida e se há abandono silencioso por incômodo com a sedação."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, bocejos, dificuldade de sustentar atenção e menor vivacidade na sessão podem aparecer logo no início do uso ou após retomadas irregulares. Em alguns pacientes isso é vivido como alívio da agitação; em outros, como embotamento incômodo ou queda de rendimento. A leitura pode se confundir com depressão, esgotamento, noites mal dormidas, uso de álcool ou outras medicações sedativas. Vale comparar com a linha de base e com o horário em que o paciente costuma tomar a medicação.

Sono e vigília: Quando usada à noite, a hidroxizina pode coincidir com melhora para iniciar o sono, mas também com despertar mais difícil, sensação de ressaca ao acordar ou sonolência residual na sessão do dia seguinte. Se o paciente relata dormir mais, isso não equivale necessariamente a sono reparador. Também pode haver confusão com reorganização recente da rotina, privação crônica de sono, ansiedade noturna em remissão parcial ou uso concomitante de cafeína e outros sedativos. O terapeuta ganha mais clareza ao observar se a mudança se concentra no início da noite, na manhã seguinte ou ao longo de todo o dia.

Ansiedade observável: Parte dos pacientes chega menos reativa, menos acelerada e com menor urgência corporal, o que pode ser lido como redução de ansiedade; em outros, a sedação apenas encobre a expressão da angústia sem ampliar elaboração. Se a pessoa parece mais calma, vale discriminar se houve de fato diminuição de ruminação, antecipação catastrófica e evitação, ou se há apenas cansaço e menor energia para reagir. Eventos de vida, melhora espontânea do quadro e expectativa positiva com o tratamento também podem produzir uma sessão aparentemente mais tranquila. O foco é distinguir contenção sintomática de mudança clínica mais ampla.

Cognição funcional: Alguns pacientes descrevem cabeça pesada, raciocínio mais lento, lapsos atencionais ou dificuldade para acompanhar leituras, trabalho e direção. Na sessão, isso pode surgir como perda do fio, necessidade de repetição ou menor capacidade associativa, sobretudo se a tomada foi recente. Esse padrão pode ser confundido com ansiedade elevada, sobrecarga, privação de sono, uso de substâncias ou sofrimento clínico de base. A utilidade clínica está em mapear se a oscilação cognitiva acompanha o uso e se está interferindo na funcionalidade cotidiana.

Adesão prática: Como a hidroxizina costuma ser percebida rapidamente no corpo, o paciente às vezes passa a usar de modo irregular conforme necessidade percebida, evitando em dias de trabalho, dirigindo ou quando teme ficar sonolento. Esse padrão pode gerar relatos inconsistentes: em uma semana parece muito útil, em outra parece ineficaz ou excessiva. A oscilação pode refletir não só o medicamento, mas também horários variáveis, associação com álcool, esquecimento ou uso apenas em momentos de maior desconforto. Na terapia, vale observar se a adesão real difere da adesão presumida e se há abandono silencioso por incômodo com a sedação.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- O dicloridrato de hidroxizina é um anti-histamínico com uso frequente quando há prurido, quadros alérgicos e, em alguns contextos, para reduzir tensão e facilitar o sono. No consultório, tende a aparecer mais pelo impacto subjetivo de sedação, lentificação e sonolência do que por mudanças emocionais específicas. Esses efeitos podem surgir já nas primeiras tomadas ou nos primeiros dias e variar bastante conforme horário de uso, sensibilidade individual e associação com outras medicações ou álcool. O ponto central na sessão é diferenciar sonolência medicamentosa de piora depressiva, apatia, privação de sono ou exaustão ligada ao contexto de vida.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais lento ou sonolento, isso aparece mais perto do horário em que toma a medicação ou permanece igual ao longo do dia todo? , Nesses dias em que você parece mais calmo, sua cabeça fica menos preocupada e menos acelerada, ou você só se sente mais cansado para reagir? , Quando perde o foco ou o fio da conversa, isso já vinha acontecendo antes desse uso atual ou ficou mais perceptível depois que a medicação entrou na rotina? , Nos dias em que você dorme melhor, acorda mais descansado e funcional ou acorda como se estivesse grogue e arrastado? , Você tem tomado sempre do mesmo jeito ou foi adaptando por conta própria conforme compromissos, sono ou medo de ficar sonolento?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a faltar
- dirigir com receio
- reduzir atividades ou evitar compromissos por sonolência persistente
- pode valer alinhar com o médico assistente para situar o impacto funcional do uso
- Quando a aparente melhora da ansiedade vem acompanhada de embotamento
- lentificação importante ou dificuldade cognitiva nova
- pode valer comunicar para ajudar a diferenciar benefício clínico de tolerabilidade ruim
- Quando o paciente descreve uso muito irregular
- retomadas frequentes ou abandono silencioso por incômodo com sedação
- pode valer alinhar com o médico assistente porque a leitura da resposta clínica fica pouco confiável
- Quando surgem confusão mais marcada
- fala muito arrastada ou rebaixamento incomum do estado de alerta
- especialmente com álcool ou outros sedativos
- pode valer contato mais breve com o médico para avaliação da segurança
- Quando não há ganho subjetivo claro em ansiedade ou sono
- mas há prejuízo funcional recorrente nas primeiras semanas de uso
- pode valer comunicar para contextualizar a experiência do paciente no acompanhamento

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente aparece muito confuso
- excessivamente sonolento
- com fala bastante arrastada ou dificuldade de se manter desperto.: Interromper a exploração psicoterápica
- avaliar segurança imediata
- acionar médico assistente e rede de apoio no mesmo dia; considerar emergência se houver rebaixamento importante
- Após uso associado a álcool ou outros sedativos
- o paciente relata episódio recente de quase desmaio
- queda
- desorientação intensa ou não lembra bem do que ocorreu.: Tratar como situação de risco agudo
- orientar busca de avaliação médica imediata e acionar rede de apoio se necessário

Frase clínica

O foco clínico é separar alívio da ansiedade de sedação excessiva, lentificação e adesão irregular que distorcem a leitura da sessão.

173 DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA; HIDROXIZINA; CLORIDRATO DE HIDROXIZINA

Substância: Dicloridrato de Hidroxizina; Hidroxizina; Cloridrato de Hidroxizina.

Nomes Comerciais: Cloridrato de Hidroxizina

Uso comum

- A hidroxizina é um anti-histamínico sedativo que costuma aparecer no consultório quando foi usada para ansiedade, insônia, prurido ou quadros alérgicos com impacto no sono. Na sessão, o mais útil é acompanhar o que muda nas primeiras tomadas e na primeira semana: sonolência, lentificação, sensação de “cabeça pesada” ou, em alguns pacientes, irritabilidade paradoxal. Como tende a ser usada de modo intermitente em parte dos casos, vale observar se a variação entre sessões acompanha dias de uso e não apenas a evolução do quadro emocional. O foco clínico é diferenciar sedação medicamentosa, alívio real da ansiedade e uso irregular que embaralha a leitura do baseline.

O paciente pode relatar

- **"Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, dificuldade de sustentar atenção e menor espontaneidade podem aparecer já no início do uso ou em dias específicos, sobretudo quando a medicação é tomada na véspera da sessão. Isso pode se confundir com retraimento depressivo, exaustão por privação de sono ou efeito de outras substâncias sedativas. Na prática, ajuda comparar o padrão da sessão com o baseline do paciente e mapear se a lentificação é contínua ou concentrada em determinados horários e dias.

Ansiedade: Alguns pacientes chegam descrevendo alívio da tensão corporal e menor urgência ansiosa, enquanto outros relatam apenas sedação sem redução clara da preocupação, da ruminação ou da evitação. Essa diferença é clinicamente importante porque um paciente mais quieto pode parecer menos ansioso sem estar, de fato, com mais elaboração ou regulação. Eventos de vida, melhora espontânea do quadro e uso situacional da medicação podem confundir essa leitura se o terapeuta tomar a aparência calma como sinônimo de melhora global.

Sono e vigília: Quando a hidroxizina entra em cena por queixa de sono, pode haver melhora para iniciar o sono e, ao mesmo tempo, ressaca matinal, dificuldade para despertar ou sensação de sono pouco restaurador. Em sessão, isso pode aparecer como cansaço, menor acesso associativo e irritabilidade por fadiga, o que às vezes se mistura com piora depressiva ou sobrecarga de rotina. Vale observar se o paciente dorme mais, mas funciona pior no dia seguinte, e se a qualidade da vigília mudou junto com o sono.

Cognição: Esquecimentos leves, sensação de raciocínio mais lento e dificuldade de acompanhar temas mais abstratos podem surgir em parte dos pacientes, especialmente quando já existe vulnerabilidade atencional ou uso concomitante de outras medicações sedativas. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como resistência, desinvestimento ou piora cognitiva do transtorno de base. O ponto é notar se a queda de nitidez mental acompanha o uso e se oscila de forma mais aguda do que seria esperado pela história clínica habitual.

Uso irregular: Como pode ser utilizada de forma eventual, conforme necessidade percebida, o terapeuta frequentemente encontra um quadro com dias muito diferentes entre si. O paciente pode atribuir a oscilação ao humor, ao estresse ou ao próprio tratamento psicoterápico, quando parte da variação talvez acompanhe dias com e sem uso. Isso não se resume a adesão "boa" ou "ruim": o dado clinicamente útil é entender o padrão concreto de uso para não confundir efeito agudo, ausência de efeito e flutuação natural do quadro."

O que observar em sessão

- **Sedação:** Sonolência, fala mais lenta, dificuldade de sustentar atenção e menor espontaneidade podem aparecer já no início do uso ou em dias específicos, sobretudo quando a medicação é tomada na véspera da sessão. Isso pode se confundir com retraimento depressivo, exaustão por privação de sono ou efeito de outras substâncias sedativas. Na prática, ajuda comparar o padrão da sessão com o baseline do paciente e mapear se a lentificação é contínua ou concentrada em determinados horários e dias.

Ansiedade: Alguns pacientes chegam descrevendo alívio da tensão corporal e menor urgência ansiosa, enquanto outros relatam apenas sedação sem redução clara da preocupação, da ruminação ou da evitação. Essa diferença é clinicamente importante porque um paciente mais quieto pode parecer menos ansioso sem estar, de fato, com mais elaboração ou regulação. Eventos de vida, melhora espontânea do quadro e uso situacional da medicação podem confundir essa leitura se o terapeuta tomar a aparência calma como sinônimo de melhora global.

Sono e vigília: Quando a hidroxizina entra em cena por queixa de sono, pode haver melhora para iniciar o sono e, ao mesmo tempo, ressaca matinal, dificuldade para despertar ou sensação de sono pouco restaurador. Em sessão, isso pode aparecer como cansaço, menor acesso associativo e irritabilidade por fadiga, o que às vezes se mistura com piora depressiva ou sobrecarga de rotina. Vale observar se o paciente dorme mais, mas funciona pior no dia seguinte, e se a qualidade da vigília mudou junto com o sono.

Cognição: Esquecimentos leves, sensação de raciocínio mais lento e dificuldade de acompanhar temas mais abstratos podem surgir em parte dos pacientes, especialmente quando já existe vulnerabilidade atencional ou uso concomitante de outras medicações sedativas. Na sessão, isso pode ser lido apressadamente como resistência, desinvestimento ou piora cognitiva do transtorno de base. O ponto é notar se a queda de nitidez mental acompanha o uso e se oscila de forma mais aguda do que seria esperado pela história clínica habitual.

Uso irregular: Como pode ser utilizada de forma eventual, conforme necessidade percebida, o terapeuta frequentemente encontra um quadro com dias muito diferentes entre si. O paciente pode atribuir a oscilação ao humor, ao estresse ou ao próprio tratamento psicoterápico, quando parte da variação talvez acompanhe dias com e sem uso. Isso não se resume a adesão “boa” ou “ruim”: o dado clinicamente útil é entender o padrão concreto de uso para não confundir efeito agudo, ausência de efeito e flutuação natural do quadro.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- A hidroxizina é um anti-histamínico sedativo que costuma aparecer no consultório quando foi usada para ansiedade, insônia, prurido ou quadros alérgicos com impacto no sono. Na sessão, o mais útil é acompanhar o que muda nas primeiras tomadas e na primeira semana: sonolência, lentificação, sensação de “cabeça pesada” ou, em alguns pacientes, irritabilidade paradoxal. Como tende a ser usada de modo intermitente em parte dos casos, vale observar se a variação entre sessões acompanha dias de uso e não apenas a evolução do quadro emocional. O foco clínico é diferenciar sedação medicamentosa, alívio real da ansiedade e uso irregular que embaralha a leitura do baseline.

Perguntas úteis

- "Nos dias em que você fica mais calmo, você percebe também menos preocupação e menos urgência interna, ou fica principalmente mais sonolento e lento? , Quando você chega mais cansado ou com a fala mais arrastada, isso costuma acontecer depois de uma noite em que você tomou a medicação, ou aparece mesmo sem uso recente? , Seu sono melhorou de um jeito que deixa o dia seguinte mais funcional, ou você dorme mais e acorda como se ainda estivesse sedado? , Quando sua atenção piora, isso vem junto com tristeza, desânimo e perda de interesse, ou parece mais uma cabeça pesada e menos nítida em certos períodos? , Essas oscilações entre um dia e outro combinam mais com algo que aconteceu na sua semana, ou com dias em que você usou a medicação e dias em que não usou?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a chegar repetidamente muito sonolento
- Identificado ou com prejuízo funcional claro no dia seguinte ao uso
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar o impacto clínico dessa sedação
- Quando a medicação parece acalmar pela sedação
- mas a ansiedade de base permanece intensa
- com ruminação
- evitação ou sofrimento relevante
- pode valer comunicar para evitar uma leitura excessivamente otimista da evolução
- Quando há uso muito irregular e o paciente não consegue mais discriminar o que é efeito da medicação
- o que é piora do quadro e o que é resposta a eventos de vida
- pode valer alinhar com o médico para qualificar a leitura clínica conjunta
- Quando surgem confusão mais marcada
- desorientação
- agitação incomum ou piora cognitiva acima do baseline
- pode valer contato com o médico assistente para avaliação mais rápida
- Quando o paciente considera interromper por conta própria porque se sente excessivamente sedado ou "apagado"
- pode valer comunicar ao médico para reduzir risco de abandono silencioso e leitura clínica distorcida

Vermelho: tratar como urgência

- Na sessão
- o paciente aparece muito confuso
- desorientado

Vermelho: tratar como urgência

- dificilmente sustentando contato ou com rebaixamento importante do nível de alerta.: Interromper o trabalho interpretativo
- acionar avaliação médica no mesmo dia e envolver rede de apoio ou emergência se necessário
- Surge agitação intensa
- inquietação incomum
- comportamento muito desorganizado ou piora abrupta do estado mental após início recente ou retomada do uso.: Tratar como mudança aguda relevante
- contatar o médico no mesmo dia e considerar suporte de urgência conforme a gravidade observada

Frase clínica

Com hidroxizina, o ponto central é separar calma por sedação de melhora real da ansiedade e mapear oscilações ligadas ao uso intermitente.

174 HIDROXIZINA

Substância: Hidroxizina.

Nomes Comerciais: Pergo, Drotizin

Uso comum

- Hidroxizina é um anti-histamínico sedativo que às vezes aparece no consultório quando o paciente está sendo tratado por ansiedade, insônia situacional, prurido ou quadros alérgicos com impacto no sono. Quando usada para aliviar tensão ou facilitar o sono, o efeito subjetivo costuma ser percebido no mesmo dia ou nos primeiros dias; por isso, na terapia, o ponto central não é esperar mudança progressiva de humor, mas observar se houve redução de ativação à custa de sonolência, lentificação ou menor acesso afetivo. Também vale acompanhar uso intermitente, variação conforme necessidade e eventual confusão entre efeito sedativo, cansaço acumulado e evolução do quadro de base.

O paciente pode relatar

- **"Sedação em sessão:** Pode surgir um paciente mais sonolento, com fala mais lenta, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar elaboração, sobretudo quando a medicação foi usada na noite anterior ou no mesmo dia. Isso pode ser lido apressadamente como retraimento depressivo, resistência ou desinvestimento do processo, quando às vezes o que predomina é rebaixamento de alerta. A comparação com a baseline da sessão, com o horário de uso e com a qualidade do sono recente ajuda a separar efeito sedativo de piora do humor ou exaustão por eventos de vida.

Ansiedade e ativação: Alguns pacientes descrevem alívio relativamente rápido da tensão corporal e da urgência ansiosa, enquanto outros seguem apreensivos, apenas mais cansados. Na sessão, isso pode aparecer como menor agitação motora sem redução proporcional de ruminação, o que diferencia contenção sintomática de elaboração emocional mais organizada. Também convém considerar se a melhora coincide apenas com momentos de uso, se houve mudança ambiental relevante ou se a adesão é irregular, porque isso altera a leitura do que de fato mudou.

Sono e dia seguinte: Quando a hidroxizina entra no manejo do sono, o terapeuta pode encontrar tanto adormecimento mais fácil quanto despertar com ressaca subjetiva, lentificação matinal ou sensação de sono pouco restaurador. Esse padrão pode ser confundido com insônia persistente, piora depressiva ou sobrecarga cotidiana, especialmente se o paciente relata dormir mais horas, mas funcionar pior no início do dia. Observar a relação entre noite de uso, qualidade do despertar e rendimento nas primeiras horas ajuda a discriminar benefício real de um sono apenas mais induzido.

Cognição e presença: Em parte dos pacientes, atenção, memória imediata e velocidade de pensamento parecem mais embotadas, o que interfere na associação livre, no acompanhamento da sessão e na capacidade de nomear estados internos. Isso pode ser tomado como evasividade, baixa motivação ou desorganização ansiosa, quando às vezes há apenas menor nitidez cognitiva naquele período. Vale notar se a oscilação é episódica, ligada ao uso, ou se acompanha um quadro mais amplo que já vinha se desenhando antes da medicação.

Uso intermitente: Como frequentemente é usada conforme necessidade, a hidroxizina pode produzir um padrão clínico irregular: sessões muito diferentes entre si, com dias de maior contenção e outros de ansiedade mais crua. Essa variabilidade pode parecer instabilidade emocional do paciente ou oscilação do quadro, mas às vezes reflete simplesmente momentos distintos de uso e não uso. Perguntar pelo contexto em que a pessoa decide tomar, evitar ou repetir a medicação ajuda a entender adesão prática, expectativas e risco de abandono silencioso por sedação incômoda."

O que observar em sessão

- **Sedação em sessão:** Pode surgir um paciente mais sonolento, com fala mais lenta, menor espontaneidade e dificuldade de sustentar elaboração, sobretudo quando a medicação foi usada na noite anterior ou no mesmo dia. Isso pode ser lido apressadamente como retraimento depressivo, resistência ou desinvestimento do processo, quando às vezes o que predomina é rebaixamento de alerta. A comparação com a baseline da sessão, com o horário de uso e com a qualidade do sono recente ajuda a separar efeito sedativo de piora do humor ou exaustão por eventos de vida.

Ansiedade e ativação: Alguns pacientes descrevem alívio relativamente rápido da tensão corporal e da urgência ansiosa, enquanto outros seguem apreensivos, apenas mais cansados. Na sessão, isso pode aparecer como menor agitação motora sem redução proporcional de ruminação, o que diferencia contenção sintomática de elaboração emocional mais organizada. Também convém considerar se a melhora coincide apenas com momentos de uso, se houve mudança ambiental relevante ou se a adesão é irregular, porque isso altera a leitura do que de fato mudou.

Sono e dia seguinte: Quando a hidroxizina entra no manejo do sono, o terapeuta pode encontrar tanto adormecimento mais fácil quanto despertar com ressaca subjetiva, lentificação matinal ou sensação de sono pouco restaurador. Esse padrão pode ser confundido com insônia persistente, piora depressiva ou sobrecarga cotidiana, especialmente se o paciente relata dormir mais horas, mas funcionar pior no início do dia. Observar a relação entre noite de uso, qualidade do despertar e rendimento nas primeiras horas ajuda a discriminar benefício real de um sono apenas mais induzido.

Cognição e presença: Em parte dos pacientes, atenção, memória imediata e velocidade de pensamento parecem mais embotadas, o que interfere na associação livre, no acompanhamento da sessão e na capacidade de nomear estados internos. Isso pode ser tomado como evasividade, baixa motivação ou desorganização ansiosa, quando às vezes há apenas menor nitidez cognitiva naquele período. Vale notar se a oscilação é episódica, ligada ao uso, ou se acompanha um quadro mais amplo que já vinha se desenhando antes da medicação.

Uso intermitente: Como frequentemente é usada conforme necessidade, a hidroxizina pode produzir um padrão clínico irregular: sessões muito diferentes entre si, com dias de maior contenção e outros de ansiedade mais crua. Essa variabilidade pode parecer instabilidade emocional do paciente ou oscilação do quadro, mas às vezes reflete simplesmente momentos distintos de uso e não uso. Perguntar pelo contexto em que a pessoa decide tomar, evitar ou repetir a medicação ajuda a entender adesão prática, expectativas e risco de abandono silencioso por sedação incômoda.

Efeitos que confundem a leitura clínica

- Hidroxizina é um anti-histamínico sedativo que às vezes aparece no consultório quando o paciente está sendo tratado por ansiedade, insônia situacional, prurido ou quadros alérgicos com impacto no sono. Quando usada para aliviar tensão ou facilitar o sono, o efeito subjetivo costuma ser percebido no mesmo dia ou nos primeiros dias; por isso, na terapia, o ponto central não é esperar mudança progressiva de humor, mas observar se houve redução de ativação à custa de sonolência, lentificação ou menor acesso afetivo. Também vale acompanhar uso intermitente, variação conforme necessidade e eventual confusão entre efeito sedativo, cansaço acumulado e evolução do quadro de base.

Perguntas úteis

- "Quando você se sente mais calmo depois de tomar, a sua cabeça também desacelera ou você fica principalmente mais sonolento, mas com as preocupações ainda ativas? , Nos dias em que você usa, o que muda primeiro: a tensão no corpo, o fluxo de pensamentos, o sono ou só a disposição no dia seguinte? , Essa dificuldade de se concentrar aqui comigo aparece mesmo em dias sem uso ou fica mais marcada perto das vezes em que você toma? , Quando você dorme melhor após usar, no dia seguinte você se sente realmente mais restaurado ou apenas mais lento e pesado? , Nas últimas semanas, as oscilações entre sessões combinaram mais com acontecimentos da sua rotina ou com dias em que você tomou e dias em que não tomou?"

Amarelo: alinhar em breve

- Quando o paciente passa a evitar situações importantes
- dirigir ou trabalhar por sonolência e lentificação que ele associa temporalmente ao uso
- pode valer alinhar com o médico assistente para revisar o impacto funcional
- Quando a ansiedade permanece praticamente inalterada
- mas o paciente fica repetidamente sedado ou cognitivamente mais embotado
- pode valer comunicar o médico para diferenciar benefício limitado de tolerabilidade ruim
- Quando aparece uso muito irregular
- com tomada repetida em momentos de crise e abandono silencioso nos demais dias por incômodo com o efeito
- pode valer contato com o médico pela chance de o padrão de uso estar confundindo a leitura clínica
- Quando o paciente relata piora importante do sono
- agitação ou mal-estar após interromper um período de uso frequente
- pode valer alinhar com o médico para esclarecer se houve relação temporal consistente com a mudança no uso

Vermelho: tratar como urgência

- Durante a sessão surgem rebaixamento importante de consciência

Vermelho: tratar como urgência

- fala muito arrastada
- desorientação ou dificuldade incomum de se manter desperto.: Interromper o trabalho interpretativo
- avaliar segurança imediata
- acionar apoio presencial se necessário e buscar contato médico no mesmo dia ou emergência conforme o estado clínico
- Aparecem falta de ar
- inchaço súbito
- sensação de desmaio iminente ou piora física aguda temporalmente próxima ao uso.: Tratar como situação médica aguda
- orientar busca de avaliação imediata e acionar rede de apoio ou emergência quando necessário

Frase clínica

O foco clínico costuma ser distinguir alívio da ansiedade de simples sedação, especialmente quando o uso é intermitente e muda muito o padrão da sessão.